

O medicamento Dipirona, cujo princípio ativo é o metamizol sódico, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, manifestando-se como uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade aumentada ou complicações, e o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente. A conduta recomendada nesses casos é interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Piperacilina+tazobactam, contendo os princípios ativos piperacilina sódica e tazobactam sódico, provocou dispneia (falta de ar) por hipersensibilidade, um quadro alérgico do sistema imunológico. A reação foi considerada grave, pois envolveu ameaça à vida e necessidade de hospitalização, o que exige suspensão imediata do medicamento e atendimento médico de urgência para estabilização e tratamento adequado. O paciente se recuperou totalmente após a intervenção.

A Deferroxamina, cujo princípio ativo é o mesilato de deferoxamina, causou dor no local de aplicação, relacionada a hipersensibilidade, um tipo de reação alérgica do sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade ou evolução do caso, e o desfecho permanece desconhecido. Em situações semelhantes, recomenda-se observar a intensidade dos sintomas e buscar orientação médica caso haja piora ou persistência.

O Ibuprofeno, com princípio ativo ibuprofeno, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade) considerada grave, pois houve ameaça à vida, exigindo suspensão imediata do medicamento e atendimento médico de emergência. O paciente se recuperou após a conduta adequada. Reações desse tipo devem ser tratadas com prioridade, e o uso futuro do medicamento deve ser evitado.

A Ampicilina, cujo princípio ativo é a ampicilina tri-hidratada, foi responsável por uma reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade aumentada ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente. Nesses casos, recomenda-se interromper o uso do medicamento e procurar avaliação médica para confirmação e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Visipaque, cujo princípio ativo é o iodixanol, foi associado a um quadro de hiperemia, que pode ser entendido como vermelhidão da pele decorrente de uma reação alérgica ao iodo. Embora não haja detalhes sobre a gravidade ou evolução do caso, reações desse tipo geralmente envolvem o sistema imunológico e podem variar de leves a moderadas, sendo importante monitorar o paciente e considerar avaliação especializada para confirmar a alergia e orientar futuras exposições a contrastes iodados.

O Cloridrato de ciprofloxacino, também conhecido como ciprofloxacin hydrochloride, foi relacionado a um episódio de alergia, tecnicamente chamado de hipersensibilidade. Não há informações sobre a gravidade ou desfecho, mas reações alérgicas a antibióticos podem se manifestar com sintomas como urticária, coceira ou inchaço, e exigem atenção médica para evitar novas exposições e orientar o tratamento adequado.

O medicamento Erbitux, cujo princípio ativo é o cetuximabe, provocou uma reação alérgica classificada como hipersensibilidade, considerada clinicamente significativa e grave, mas o paciente se recuperou totalmente. Reações desse tipo podem envolver sintomas intensos, como dificuldade para respirar ou queda de pressão, e exigem intervenção médica imediata e acompanhamento especializado para evitar riscos em futuras administrações.

A petidina, também chamada de pethidine hydrochloride, foi associada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), com relato de recuperação completa do paciente. Embora não haja detalhes sobre a gravidade, reações alérgicas a analgésicos opioides podem variar de manifestações leves, como coceira, até quadros mais sérios, sendo fundamental evitar nova exposição e buscar orientação médica.

O medicamento Dimorf, cujo princípio ativo é o sulfato de morfina, foi relacionado a uma reação de alergia a contraste, mas não há informações sobre a gravidade ou evolução do caso. Reações desse tipo envolvem o sistema imunológico e podem se manifestar com sintomas como vermelhidão, coceira ou dificuldade respiratória,

sendo importante investigar a relação com o contraste utilizado e orientar o paciente sobre riscos em futuras exposições.

O medicamento Torsilax, que contém cafeína, carisoprodol, diclofenaco sódico e paracetamol, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do sistema imunológico. Neste caso, a gravidade foi considerada uma ameaça à vida, evidenciada pela classificação clínica e pela necessidade de acompanhamento rigoroso, sendo que o paciente encontra-se em recuperação ou com resolução dos sintomas.

A quetiapina, cujo princípio ativo é o quetiapine fumarate, foi relacionada ao sintoma de boca seca, que pode estar associado a uma reação de hipersensibilidade, embora não haja informações suficientes sobre a gravidade, desfecho ou conduta adotada neste caso específico.

O diclofenaco, aqui registrado como diclofenac diethylamine, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), indicando uma resposta do sistema imunológico ao medicamento; o paciente está em processo de recuperação ou resolução do quadro, mas não há detalhes sobre a gravidade ou conduta adotada.

O medicamento tramadol, cujo princípio ativo é tramadol hydrochloride, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade), manifestando-se como resposta do sistema imunológico, e o paciente já se encontra recuperado ou com resolução completa dos sintomas, sem informações adicionais sobre a gravidade do evento.

O Visipaque, que tem como princípio ativo o iodixanol, foi relacionado ao sintoma de fraqueza, possivelmente como manifestação de hipersensibilidade, mas não há informações suficientes sobre a gravidade, evolução do quadro ou conduta adotada neste caso.

O medicamento Fenitoína (princípio ativo Phenytoin) foi associado a um quadro de alergia, descrito como hipersensibilidade, que se enquadra nos distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade, mas o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, indicando a necessidade de atenção clínica em casos semelhantes.

O medicamento Tramadol (princípio ativo Tramadol hydrochloride) esteve relacionado a um episódio de alergia, caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não foram relatados sintomas graves e o caso foi considerado não grave, com resolução completa após a reação. A ligação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, sugerindo monitoramento em futuras administrações.

O medicamento Tevacarbo (princípio ativo Carboplatin) foi associado a uma reação alérgica, descrita como hipersensibilidade, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre sintomas graves e o caso foi considerado não grave, com recuperação total do paciente. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, recomendando-se cautela em novas exposições.

O medicamento Clavulin bd (princípios ativos Amoxicillin trihydrate e Clavulanate potassium) foi relacionado ao agravamento da doença, manifestando-se como hipersensibilidade, o que indica uma reação alérgica dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhes sobre gravidade, desfecho ou conduta adotada, mas a relação com o medicamento foi considerada suspeita, sendo importante avaliar cuidadosamente o histórico do paciente em situações semelhantes.

O medicamento Bromoprida (princípio ativo Bromopride) esteve envolvido em um caso de alergia, descrito como hipersensibilidade, classificado como clinicamente significativo e grave, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. O paciente se recuperou totalmente após a reação, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita, indicando a necessidade de atenção especial em futuras administrações.

O medicamento Ciprofloxacina, cujo princípio ativo é o ciprofloxacina lactate, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações, e o paciente apresentou recuperação completa após o evento. A conduta recomendada em casos semelhantes é interromper o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Butilbrometo de escopolamina + dipirona sódica, com princípios ativos hyoscine butylbromide e metamizole sodium, foi relacionado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente. Em situações como essa, recomenda-se suspender o uso do medicamento e procurar orientação médica para avaliação e prevenção de novas exposições.

O medicamento Ondansetron, com princípio ativo ondansetron, esteve associado a uma reação alérgica classificada como hipersensibilidade, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente evoluiu para recuperação completa. A conduta adequada é interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação da alergia e definição de alternativas terapêuticas.

O medicamento Penicilina, cujo princípio ativo é benzylpenicillin sodium, foi relacionado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não houve gravidade significativa e o paciente se recuperou totalmente após o evento. Recomenda-se evitar novas exposições ao medicamento e realizar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Buscopan composto, com princípios ativos hyoscine butylbromide e metamizole sodium, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade aumentada e o paciente apresentou recuperação completa. A conduta recomendada é suspender o uso do medicamento e procurar avaliação médica para confirmação da alergia e orientação sobre opções seguras.

O medicamento Bexsero, que contém como princípio ativo a vacina meningocócica B (Meningococcal vaccine B rHbp/NadA/NHBA OMV), foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação alérgica do tipo clínico, envolvendo o sistema imunológico. A gravidade do evento foi considerada alta, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, o que indica a necessidade de monitoramento e intervenção médica imediata. O desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente após a reação.

O medicamento Carboplatina, cujo princípio ativo é o carboplatina, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação alérgica clínica envolvendo o sistema imunológico. O evento foi considerado grave devido ao impacto clinicamente significativo, exigindo atenção médica especializada. O paciente evoluiu para recuperação total após a reação.

O medicamento Tazocin, composto por piperacilina sódica e tazobactam sódico, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade), descrita como um quadro clínico alérgico envolvendo o sistema imunológico. A gravidade foi considerada significativa por ter outro efeito clinicamente relevante, o que justifica a necessidade de avaliação médica. O paciente se recuperou completamente após o evento.

O medicamento Dimorf, cujo princípio ativo é o sulfato de morfina, esteve envolvido em um episódio de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação alérgica clínica do sistema imunológico. O evento foi classificado como grave devido ao seu impacto clínico relevante, exigindo acompanhamento médico. O paciente apresentou recuperação total após a reação.

O medicamento Vancomicina, com princípio ativo vancomicina hidrocloreídrica, foi relacionado a uma reação alérgica (hipersensibilidade), manifestando-se como um quadro clínico alérgico do sistema imunológico. O evento foi considerado grave por apresentar outro efeito clinicamente significativo, o que demanda atenção médica. O

paciente evoluiu para recuperação completa após o episódio.

O medicamento Cetoprofeno, cujo princípio ativo é o ketoprofen sodium, esteve envolvido em um erro de prescrição que resultou em uma reação de hipersensibilidade (alergia), classificada como um quadro clínico alérgico relacionado ao sistema imunológico. Não há indicação de gravidade importante ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente após a conduta adequada, sem evolução para quadros graves.

O Glucantime, que tem como princípio ativo o meglumine antimonate, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado como clinicamente significativo e relacionado ao sistema imunológico. O evento foi considerado grave devido à sua relevância clínica, mas o paciente encontra-se em recuperação, demonstrando resposta positiva à conduta adotada.

A Dipirona, cujo princípio ativo é o metamizole sodium, foi relacionada a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), envolvendo o sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade aumentada ou complicações, e o paciente se recuperou completamente após a suspensão do medicamento.

O Sulfato de Polimixina B, com princípio ativo polymyxin b sulfate, esteve associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) envolvendo o sistema imunológico, sem detalhes adicionais sobre gravidade, evolução ou desfecho, impossibilitando uma avaliação mais precisa da conduta e evolução clínica.

O Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, foi relacionado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) envolvendo o sistema imunológico, sem indicação de gravidade aumentada, e o paciente apresentou recuperação completa após a conduta adequada.

O medicamento Sulfato de neomicina (princípio ativo: Neomycin sulfate) foi associado a um quadro de alergia, caracterizado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações, e o paciente apresentou recuperação completa após o evento. A conduta recomendada é evitar nova exposição ao medicamento e, caso haja necessidade de uso futuro, buscar orientação médica para alternativas seguras.

A Fluoresceína (princípio ativo: Fluorescein sodium) foi relacionada a uma reação alérgica ao contraste intravenoso, classificada como alergia a contraste e enquadrada entre os distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhes sobre gravidade ou desfecho, portanto, recomenda-se cautela em futuras exposições e avaliação prévia com especialista em casos de necessidade de novos exames com contraste.

O medicamento Dipirona (princípio ativo: Metamizole sodium) desencadeou uma reação alérgica, descrita como hipersensibilidade e pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente. A orientação é evitar o uso futuro da dipirona e consultar um médico para alternativas seguras em caso de necessidade de analgésicos ou antitérmicos.

O medicamento Optiray 320 (princípio ativo: Ioversol) provocou uma reação alérgica, caracterizada como hipersensibilidade e relacionada a distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente apresentou resolução completa do quadro. Recomenda-se evitar o uso futuro deste contraste e buscar avaliação médica para alternativas em exames que exijam contraste iodado.

O medicamento Metronidazol (princípio ativo: Metronidazole benzoate) foi associado a uma reação alérgica, descrita como hipersensibilidade e pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente. A recomendação é evitar o uso futuro do metronidazol e consultar um médico para opções alternativas em caso de necessidade de tratamento antimicrobiano.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de

gravidade elevada neste caso, e o paciente apresentou recuperação completa após o evento. A conduta recomendada envolve a suspensão do agente suspeito e acompanhamento clínico, reforçando a importância de relatar reações alérgicas a contrastes para evitar futuras exposições.

A ranitidina, cujo princípio ativo é o ranitidine hydrochloride, desencadeou uma reação alérgica classificada como hipersensibilidade, relacionada a distúrbios do sistema imunitário. O caso foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando a importância de monitoramento rigoroso e intervenção médica imediata. O paciente evoluiu para recuperação completa após a conduta adequada, que inclui a suspensão do medicamento e suporte clínico conforme protocolos de alergia medicamentosa.

A ampicilina, com princípio ativo ampicillin, foi relacionada a um episódio de alergia do tipo hipersensibilidade, enquadrado nos distúrbios do sistema imunitário. Não há informações detalhadas sobre a gravidade, desfecho ou conduta adotada neste caso, sendo fundamental que, diante de suspeita de reação alérgica a antibióticos, o medicamento seja suspenso e o paciente avaliado por um especialista para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas terapêuticas seguras.

O medicamento Cisplatina, cujo princípio ativo é cisplatin, foi associado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa após a reação, indicando que a conduta de suspensão do agente e acompanhamento clínico foi suficiente para resolução do quadro.

O Dramin, com princípio ativo dimenidrinato, esteve relacionado a um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo que a suspensão do medicamento e observação clínica foram medidas adequadas para o manejo da reação.

O medicamento Vancomicina (princípio ativo: Vancomycin hydrochloride) foi associado a um quadro de alergia, caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. A reação foi considerada leve, pois não há indicação de gravidade clínica relevante e o paciente se recuperou totalmente após o evento, não sendo necessário relatar complicações adicionais.

O medicamento Hierro sacarato (princípio ativo: Saccharated iron oxide) provocou uma reação de alergia medicamentosa, descrita como hipersensibilidade medicamentosa, relacionada a distúrbios do sistema imunitário. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, pois houve indicação explícita de gravidade, mas o paciente evoluiu para recuperação completa após a conduta adequada.

O medicamento Glucantime (princípio ativo: Meglumine antimonate) desencadeou um quadro de febre relacionado à hipersensibilidade, classificado como distúrbio do sistema imunitário. A reação foi grave, resultando em óbito, o que evidencia a necessidade de atenção máxima e conduta imediata em casos semelhantes.

O medicamento Dipirona (princípio ativo: Metamizole sodium) foi relacionado a uma alergia documentada após administração, caracterizada como hipersensibilidade documentada ao produto, enquadrando-se em lesões, intoxicações e complicações de procedimentos. Não há informações suficientes sobre gravidade, evolução clínica ou desfecho, impossibilitando detalhar a conduta ou o resultado final do caso.

O medicamento Sulphan blue (princípio ativo: Sulphan blue) foi associado a um quadro de alergia, descrito como hipersensibilidade e classificado como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, não havendo necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Ceftriaxona (princípio ativo: Ceftriaxone sodium) foi associado a um quadro de alergia, descrito como hipersensibilidade, pertencente ao grupo de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A relação entre o uso do medicamento e

a reação foi considerada suspeita, e a conduta adequada inclui evitar novas exposições e buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação futura.

O medicamento Docetaxel (princípio ativo: Docetaxel) esteve relacionado a um episódio de alergia, caracterizado como hipersensibilidade, dentro do contexto de distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa relatadas, e o desfecho do caso permanece desconhecido. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, sendo importante monitorar o paciente e considerar avaliação médica para esclarecimento e prevenção de novas reações.

O medicamento Hidrocortisona (princípio ativo: Hydrocortisone butyrate) provocou uma reação alérgica classificada como hipersensibilidade, com gravidade de ameaça à vida, evidenciada pela indicação de gravidade elevada e necessidade de atenção imediata. O paciente se recuperou após o evento, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita. Diante de reações graves como esta, é fundamental evitar novas exposições, garantir acompanhamento médico e registrar o evento para orientar futuras condutas.

O medicamento Ceftriaxona (princípio ativo: Ceftriaxone sodium) foi responsável por uma reação alérgica grave, classificada como hipersensibilidade com ameaça à vida, o que exige atenção clínica imediata. Apesar da gravidade, o paciente se recuperou totalmente após o episódio. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, sendo essencial evitar novas administrações e buscar acompanhamento especializado para prevenção de recorrências.

O medicamento Musculare (princípio ativo: Cyclobenzaprine hydrochloride) desencadeou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, considerada clinicamente significativa devido à gravidade relatada. O paciente se recuperou após o evento, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita. Em situações como esta, recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e realizar avaliação médica para orientação e segurança em tratamentos posteriores.

O medicamento Cipro, cujo princípio ativo é o ciprofloxacino, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, manifestação que faz parte dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo um episódio leve e autolimitado. A conduta recomendada é evitar novas exposições ao medicamento e buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O Artrinid, que contém cetoprofeno como princípio ativo, desencadeou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, relacionada a distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave, já que houve recuperação completa do paciente, indicando um episódio leve. Recomenda-se evitar o uso futuro do cetoprofeno e consultar um alergista para avaliação detalhada e definição de opções terapêuticas seguras.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromida, provocou uma reação alérgica classificada como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi grave, pois o paciente se recuperou totalmente, sugerindo um quadro leve. A orientação é evitar novas exposições ao contraste e realizar acompanhamento com especialista para avaliação de risco em procedimentos futuros.

O Buscopan composto, que contém hioscina butilbrometo e metamizol sódico, foi relacionado a uma alergia medicamentosa do tipo hipersensibilidade, enquadrada entre as reações a medicamentos e outras substâncias químicas. O episódio não foi grave, já que houve resolução completa dos sintomas, indicando um quadro leve. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e buscar orientação médica para alternativas seguras e confirmação diagnóstica.

O Henetix, cujo princípio ativo é o iobitridol, foi associado a uma reação alérgica ocular, caracterizada por sintomas nos olhos e relacionada a distúrbios oculares. O caso não foi grave, pois o paciente se recuperou totalmente, indicando um episódio leve. A conduta recomendada é evitar novas exposições ao contraste e consultar um

especialista para avaliação de risco em futuras utilizações.

O medicamento Dipirona, cujo princípio ativo é o metamizol sódico, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente após a reação. A conduta recomendada em situações de hipersensibilidade leve é a suspensão do medicamento e acompanhamento clínico, com orientação para evitar novas exposições ao fármaco.

O medicamento Oxacilina, com princípio ativo oxacillin, foi relacionado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, enquadrada entre os distúrbios do sistema imunitário. Não há informações detalhadas sobre a gravidade ou desfecho do caso, mas, em geral, quadros de hipersensibilidade a antibióticos exigem suspensão imediata do uso e avaliação médica para manejo dos sintomas e prevenção de complicações.

O contraste Omnipaque, cujo princípio ativo é o iohexol, desencadeou uma reação alérgica classificada como hipersensibilidade, pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente após a reação. Em casos de hipersensibilidade leve a contrastes, recomenda-se evitar novas exposições e informar a equipe médica sobre o histórico para futuras indicações de exames.

O medicamento Rituximab, com o mesmo princípio ativo, foi associado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, dentro da categoria de distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação total após o evento. Em situações semelhantes, a conduta inclui suspensão do medicamento e monitoramento dos sintomas, com orientação para evitar reexposição.

O medicamento Escopolamina, cujo princípio ativo é o hioscina hidrobrometo, foi relacionado a uma reação alérgica caracterizada como hipersensibilidade, enquadrada entre os distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente. Nessas situações, recomenda-se interromper o uso do medicamento e realizar acompanhamento clínico, orientando o paciente a evitar futuras exposições ao mesmo princípio ativo.

O medicamento Prometazina, cujo princípio ativo é Promethazine hydrochloride, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, manifestação comum de reações alérgicas a medicamentos. Não há indicação de gravidade aumentada ou necessidade de hospitalização neste caso, e o paciente evoluiu para recuperação completa após a reação, sugerindo um evento leve e autolimitado.

A Ceftriaxona, com princípio ativo Ceftriaxone, foi relacionada a um episódio de alergia do tipo hipersensibilidade, quadro típico de reações alérgicas a antibióticos. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou necessidade de hospitalização, portanto, não é possível afirmar a intensidade do evento ou a conduta adotada, apenas que a relação com o medicamento é suspeita.

O medicamento Meropenem, cujo princípio ativo é Meropenem trihydrate, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade) que exigiu hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando gravidade clínica relevante. Apesar da gravidade, o paciente se recuperou totalmente após a reação, indicando resolução do quadro após as medidas necessárias.

A Amicacina, com princípio ativo Amikacin, foi responsável por uma reação alérgica (hipersensibilidade) que levou à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, caracterizando um evento grave. O paciente evoluiu para recuperação completa após a reação, mostrando que a conduta adotada foi eficaz para resolução do quadro.

O medicamento Vancomycin, cujo princípio ativo é Vancomycin, provocou uma reação alérgica (hipersensibilidade) que resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, o que indica gravidade significativa do evento. O

paciente se recuperou totalmente após a reação, demonstrando que a intervenção clínica foi adequada para resolução do caso.

O medicamento Fenoterol, cujo princípio ativo também é fenoterol, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há informações detalhadas sobre a gravidade, desfecho ou evolução do caso, portanto, recomenda-se considerar a possibilidade de reação alérgica e buscar avaliação médica para confirmação e orientação adequada, especialmente se houver sintomas respiratórios ou cutâneos após o uso.

A penicilina G potássica (princípio ativo: benzilpenicilina potássica) foi relacionada a um episódio de alergia, descrito como hipersensibilidade, dentro do contexto de distúrbios do sistema imunitário. O caso evoluiu para recuperação completa, indicando que a reação foi controlada e resolvida, mas reforça a importância de evitar reexposição ao medicamento e de informar profissionais de saúde sobre o histórico de alergia a penicilinas.

O medicamento Somalgin cardio, que contém ácido acetilsalicílico, glicinato de alumínio e carbonato de magnésio, foi associado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, classificada como distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e encontra-se em processo de recuperação, sugerindo que a reação está sendo resolvida, mas é fundamental evitar o uso futuro do medicamento e procurar orientação médica para manejo e prevenção de novas reações.

O medicamento Revlimid, cujo princípio ativo é a lenalidomida, foi relacionado a um quadro de alergia do tipo hipersensibilidade, enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave e está em recuperação, indicando que o evento está sendo controlado, mas é importante manter acompanhamento médico para monitorar a evolução e evitar reexposição ao fármaco.

O medicamento Revlimid, com princípio ativo lenalidomida, apresentou novamente um caso de alergia do tipo hipersensibilidade, pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. Assim como no caso anterior, a reação não foi grave e está em processo de resolução, sendo recomendada a continuidade do acompanhamento médico e a suspensão do uso do medicamento até avaliação especializada.

O medicamento Simeticone, cujo princípio ativo também é simeticone, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente após a reação. A conduta recomendada em situações de alergia leve a medicamentos é interromper o uso e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições.

A Ocitocina, com princípio ativo oxitocina, desencadeou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, já que o paciente se recuperou completamente. Em casos de alergia leve a medicamentos, recomenda-se suspender o uso do agente suspeito e procurar orientação médica para avaliação e prevenção de novas reações.

A Dipirona, cujo princípio ativo é metamizol sódico, foi relacionada a um episódio de alergia manifestado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. O caso não apresentou gravidade significativa, pois foi classificado como não grave e o paciente evoluiu para recuperação completa. Nessas situações, a recomendação é interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Ranitidina, com princípio ativo ranitidina, esteve envolvido em uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não houve gravidade relevante, já que o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta adequada em casos de alergia leve é suspender o uso do medicamento e consultar um profissional de saúde para avaliação e definição de condutas futuras.



O Ondansetron, cujo princípio ativo é ondansetrona, foi associado a uma reação alérgica caracterizada por hipersensibilidade, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou completamente. Em situações de alergia leve a medicamentos, recomenda-se interromper o uso e procurar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre o manejo em futuras exposições.

O medicamento Bupivacaiheavy, cujo princípio ativo é o cloridrato de bupivacaína, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada em situações de hipersensibilidade leve é a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento clínico, com resolução espontânea dos sintomas.

A morfina, identificada tanto pelo nome comercial quanto pelo princípio ativo, esteve relacionada a um episódio de alergia descrito como hipersensibilidade, enquadrado nos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa. Em casos leves de hipersensibilidade à morfina, a orientação é interromper o uso do medicamento e monitorar a evolução clínica, o que foi suficiente para resolução do quadro.

A cefazolina, cujo princípio ativo é o cefazolin sodium, foi associada a uma reação alérgica classificada como hipersensibilidade, dentro do contexto de distúrbios do sistema imunitário. Não houve gravidade significativa, já que o caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou. Nessas situações, recomenda-se suspender o uso do antibiótico e realizar acompanhamento médico, o que geralmente leva à resolução dos sintomas.

O medicamento Morfina, identificado tanto pelo nome comercial quanto pelo princípio ativo, foi relacionado a uma alergia medicamentosa descrita como hipersensibilidade medicamentosa, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente. Em casos leves de hipersensibilidade à morfina, a conduta adequada é interromper o uso do medicamento e observar a evolução clínica, o que resultou em resolução do quadro.

A adenosina, identificada pelo princípio ativo, esteve associada a um episódio de alergia medicamentosa classificado como hipersensibilidade medicamentosa, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há informações suficientes sobre a gravidade ou desfecho do caso, portanto, a recomendação é que, diante de suspeita de reação alérgica à adenosina, o medicamento seja suspenso e o paciente avaliado por um profissional de saúde para definição da conduta e monitoramento dos sintomas.

O medicamento Optiray 350, cujo princípio ativo é o ioversol, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações clínicas relevantes neste caso, pois não foi relatado desfecho grave nem evolução desfavorável. A reação sugere um quadro leve de alergia medicamentosa, sendo importante evitar novas exposições e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O Dimorf, que contém o princípio ativo morfina (morphine sulfate), foi relacionado a uma reação de alergia medicamentosa, tecnicamente chamada de hipersensibilidade medicamentosa, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente evoluiu para recuperação completa, indicando que a reação foi leve e controlada. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e consultar um especialista para avaliação e orientação sobre alternativas analgésicas seguras.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromida, foi associado a uma alergia a contraste intravenoso, classificada como alergia a contraste e pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, sugerindo um quadro leve de hipersensibilidade. É fundamental evitar novas exposições ao mesmo contraste e informar a equipe médica sobre o histórico de reação para planejamento de exames futuros com alternativas seguras.

O Docetaxel, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a uma alergia medicamentosa, tecnicamente denominada hipersensibilidade medicamentosa, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. O caso não apresentou gravidade significativa e o paciente se recuperou, indicando uma reação leve. Recomenda-se evitar o uso futuro do docetaxel e buscar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e discussão de opções terapêuticas alternativas.

A vancomicina, cujo princípio ativo é vancomicina, foi associada a um quadro de alergia classificado como hipersensibilidade, pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. Não houve gravidade relevante e o paciente se recuperou, sugerindo uma reação leve. É importante evitar novas exposições ao medicamento e informar profissionais de saúde sobre o histórico de alergia para prevenir recorrências.

O medicamento Optiray 350, cujo princípio ativo é o ioversol, foi associado a um episódio de alergia a iodo, caracterizado como uma reação do sistema imunológico a substâncias químicas. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento, e não há menção de complicações ou necessidade de intervenções adicionais. A conduta recomendada em casos semelhantes é evitar novas exposições ao agente suspeito e buscar avaliação com especialista para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

Optiray 350, contendo ioversol, esteve relacionado a uma reação alérgica ao iodo, manifestando-se como resposta imunológica a uma substância química. O caso não foi considerado grave, já que o paciente se recuperou completamente, e não há relato de consequências prolongadas. Recomenda-se evitar o uso futuro do mesmo contraste e consultar um alergista para avaliação detalhada e definição de conduta em exames futuros que exijam contraste.

O medicamento Docetaxel, com princípio ativo docetaxel, foi associado a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma alergia desencadeada pelo uso do remédio. O evento não foi classificado como grave, pois o paciente se recuperou sem complicações, e não há relato de necessidade de medidas emergenciais. Em situações como essa, é importante suspender o uso do medicamento suspeito e encaminhar para avaliação especializada para confirmação e orientação sobre alternativas terapêuticas.

A morfina, cujo princípio ativo é o sulfato de morfina, foi relacionada a um episódio de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. O caso não apresentou gravidade significativa, já que o paciente se recuperou totalmente, sem relato de complicações ou necessidade de intervenções adicionais. A recomendação é evitar o uso futuro do medicamento e buscar avaliação com alergista para esclarecimento diagnóstico e orientação sobre opções seguras de analgesia.

O medicamento Gadovist, com princípio ativo gadobutrol, foi associado a um quadro de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há informações detalhadas sobre a gravidade ou evolução do caso, nem sobre a conduta adotada, o que limita a avaliação clínica completa. Em situações semelhantes, recomenda-se evitar nova exposição ao agente suspeito e procurar avaliação especializada para investigação e orientação adequada.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade clínica relevante neste caso, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, e a conduta adequada inclui evitar novas exposições e informar o médico sobre o episódio para futuras avaliações.

O medicamento Amoxicilina + Clavulanato de Potássio, contendo amoxicilina tri-hidratada e clavulanato de potássio, foi relacionado a um episódio de diarreia, interpretado como manifestação de hipersensibilidade (alergia). Não há evidências de gravidade significativa neste caso, e o paciente apresentou recuperação completa após o evento. A relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo importante relatar o ocorrido ao médico para

orientação sobre o uso futuro e possíveis alternativas.

O medicamento Amicacina, cujo princípio ativo é o sulfato de amicacina, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade) classificado como clinicamente significativo, o que indica gravidade aumentada. O paciente se recuperou após o evento, mas a gravidade foi confirmada pela presença de um efeito clinicamente relevante, exigindo atenção médica imediata e contraindicação de novas exposições ao medicamento. A relação entre o uso e a reação foi considerada suspeita.

O medicamento Sulfametoxazol/trimetoprim, composto por sulfametoxazol e trimetoprima, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), sem sinais de gravidade importante. O paciente se recuperou totalmente após o evento, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Recomenda-se informar o médico sobre o episódio para avaliação de alternativas terapêuticas e evitar novas exposições.

O medicamento Adenosina, cujo princípio ativo é a adenosina, foi associado a uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), sem sinais de gravidade relevante. O paciente se recuperou completamente após o evento, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. É importante comunicar o episódio ao médico para registro e orientação sobre o uso futuro.

O medicamento Mabthera, cujo princípio ativo é o rituximabe, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, manifestando-se como uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade aumentada ou complicações clínicas relevantes neste caso, e o paciente se recuperou totalmente após a reação, não sendo necessário relatar efeitos graves ou intervenções adicionais.

O Optiray 320, que contém ioversol como princípio ativo, provocou uma reação de alergia do tipo hipersensibilidade, evidenciando uma resposta do sistema imunológico sem sinais de gravidade ou complicações importantes. O paciente evoluiu para recuperação completa, não havendo necessidade de medidas emergenciais ou relato de efeitos graves.

O medicamento Ontax, cujo princípio ativo é o paclitaxel, esteve relacionado a dor lombar atribuída a uma reação de hipersensibilidade, indicando um quadro alérgico leve do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade aumentada ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente após o evento.

A benzilpenicilina potássica (benzylpenicillin potassium) foi associada a um episódio de alergia à penicilina, caracterizado como hipersensibilidade medicamentosa, o que representa um efeito clinicamente significativo e potencialmente grave, conforme destacado no registro. Apesar da gravidade, o paciente se recuperou completamente após a reação, indicando resolução do quadro após as medidas adotadas.

O medicamento Ontax, com paclitaxel como princípio ativo, causou desconforto na cavidade oral relacionado a uma reação de hipersensibilidade, caracterizando um quadro alérgico leve do sistema imunológico. Não houve sinais de gravidade ou complicações, e o paciente apresentou recuperação total após o evento.

O medicamento Dimorf, cujo princípio ativo é o sulfato de morfina, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como clinicamente significativo e considerado grave, conforme evidenciado pela classificação de gravidade e pelo impacto clínico relevante. A reação foi resolvida após as medidas adotadas, e o paciente se recuperou totalmente. Em situações como essa, é fundamental interromper o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para manejo adequado, já que reações alérgicas a opioides podem variar de leves a graves.

O medicamento Gadovist, que contém o princípio ativo gadobutrol, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como não grave e com desfecho favorável, já que o paciente se recuperou completamente. Reações alérgicas a agentes de contraste como o gadobutrol geralmente são leves, mas é importante monitorar o paciente e evitar reexposição sem avaliação médica.

O Profenid, cujo princípio ativo é o cetoprofeno, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade) considerada não grave, com resolução completa dos sintomas após as medidas adotadas. Reações desse tipo a anti-inflamatórios não esteroides são relativamente comuns e, mesmo em casos leves, recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e consultar um especialista para avaliação.

O medicamento Iobitridol, que tem como princípio ativo o próprio iobitridol, foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade) não grave, com recuperação total do paciente. Reações alérgicas a contrastes iodados costumam ser leves, mas é importante informar a equipe médica sobre o histórico para evitar novas exposições sem avaliação prévia.

O Pantocal, cujo princípio ativo é o pantoprazol sódico sesquihidratado, foi relacionado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) não grave, com desfecho favorável e recuperação completa do paciente. Embora reações alérgicas a inibidores de bomba de próton sejam raras, recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e buscar orientação médica para alternativas seguras.

O medicamento Metronidazol, cujo princípio ativo é o metronidazole benzoate, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, sem gravidade significativa relatada. O paciente apresentou sintomas compatíveis com reações alérgicas do sistema imune, mas não houve ameaça à vida e o desfecho foi favorável, com recuperação completa após a conduta adequada.

O Fluconazol, com princípio ativo fluconazole, desencadeou uma reação de alergia do tipo hipersensibilidade, manifestando sintomas típicos de resposta imunológica sem gravidade importante. Não há relato de ameaça à vida e o paciente evoluiu para recuperação total após a suspensão ou manejo do medicamento.

A Oxaliplatina, cujo princípio ativo é oxaliplatin, provocou uma reação alérgica medicamentosa classificada como hipersensibilidade medicamentosa, com gravidade elevada e ameaça à vida, evidenciada pela descrição clínica. Apesar da gravidade, o paciente foi recuperado após intervenção médica adequada, demonstrando a importância do reconhecimento e manejo imediato dessas reações.

A Carboplatina, com princípio ativo carboplatin, foi responsável por uma reação alérgica medicamentosa grave, caracterizada por hipersensibilidade medicamentosa e risco à vida, conforme evidenciado pela classificação clínica. O paciente foi recuperado após as medidas necessárias, ressaltando a necessidade de vigilância e pronta intervenção em casos de alergia a quimioterápicos.

O medicamento Henetix, cujo princípio ativo é iobitridol, desencadeou uma reação alérgica medicamentosa do tipo hipersensibilidade, sem gravidade significativa relatada. O quadro foi resolvido com recuperação completa do paciente, indicando que a conduta adotada foi eficaz para o controle da reação.

O medicamento Evotaxel, cujo princípio ativo é o paclitaxel, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi resolvido com recuperação completa do paciente, e não há menção de complicações graves. A conduta recomendada em situações de hipersensibilidade leve é a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento clínico, com encaminhamento ao especialista se necessário.

O medicamento Paclitaxel, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a uma reação de alergia medicamentosa, tecnicamente chamada de hipersensibilidade medicamentosa, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade importante, já que o paciente se recuperou totalmente e não houve evolução para quadros graves. Em casos assim, recomenda-se interromper o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação e orientação sobre alternativas terapêuticas.

A Oxaliplatina, cujo princípio ativo é oxaliplatina, foi associada a um episódio de alergia medicamentosa, classificada como hipersensibilidade medicamentosa e relacionada a distúrbios do sistema imunitário. Não há informações que indiquem gravidade significativa, pois o paciente se recuperou sem complicações. Nessas situações, a recomendação é suspender o uso do medicamento suspeito e realizar acompanhamento médico para evitar novas exposições e avaliar opções de tratamento.

O medicamento Paclitaxel, com princípio ativo paclitaxel, esteve envolvido em um caso de alergia medicamentosa, tecnicamente denominada hipersensibilidade medicamentosa, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade, já que o paciente se recuperou completamente. A conduta adequada é interromper o uso do medicamento e buscar orientação médica para confirmação diagnóstica e definição de alternativas seguras.

A Oxaliplatina, cujo princípio ativo é oxaliplatina, foi relacionada a uma reação de alergia medicamentosa, classificada como hipersensibilidade medicamentosa e enquadrada nos distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação total. Nessas situações, recomenda-se suspender o medicamento suspeito e realizar acompanhamento médico para evitar recorrências e garantir a segurança do paciente.

O medicamento Docetaxel, cujo princípio ativo também é Docetaxel, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa, tecnicamente chamada de hipersensibilidade medicamentosa. Essa reação faz parte dos distúrbios do sistema imunitário e, neste caso, não foi considerada grave, pois não há menção de ameaça à vida ou complicações importantes. O paciente se recuperou totalmente após o evento, indicando resolução completa do quadro alérgico.

O medicamento Paclitaxel, com princípio ativo Paclitaxel, desencadeou uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), classificada como grave devido à ameaça à vida, conforme registrado. Esse tipo de reação envolve o sistema imunológico e pode exigir intervenção médica imediata. Apesar da gravidade, o paciente se recuperou totalmente após o episódio.

O medicamento Irinotecano, cujo princípio ativo é Irinotecan hydrochloride, foi relacionado a um episódio de dispneia (falta de ar) por hipersensibilidade, um quadro alérgico que afeta o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade aumentada neste caso, e o paciente apresentou recuperação completa após o evento.

O medicamento Zinforo, com princípio ativo Ceftaroline fosamil acetate, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade aumentada, e o paciente se recuperou totalmente após o episódio.

O medicamento Henetix, cujo princípio ativo é lobitridol, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), envolvendo o sistema imunológico. Não há menção de gravidade aumentada, e o paciente apresentou recuperação completa após o evento.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi resolvido sem complicações e o paciente se recuperou totalmente. A conduta recomendada em situações de hipersensibilidade leve é interromper a exposição ao agente suspeito, monitorar sintomas e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições.

O medicamento Tazocin, composto por piperacilina sódica e tazobactam sódico, foi relacionado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, enquadrada nos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, já que o paciente se recuperou completamente. Em casos de hipersensibilidade leve, recomenda-se suspender o uso do medicamento, observar a evolução dos sintomas e procurar orientação médica para evitar novas exposições e definir alternativas terapêuticas seguras.

O medicamento Paclitaxel, com princípio ativo de mesmo nome, esteve associado a uma reação alérgica classificada como hipersensibilidade, dentro do espectro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade importante, pois o paciente evoluiu para recuperação total. Nessas situações, a recomendação é interromper o uso do agente suspeito, monitorar sintomas e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e planejamento de futuras condutas.

O medicamento Omnipaque, cujo princípio ativo é o iohexol, foi relacionado a uma alergia a meios de contraste iodados, caracterizada como reação de hipersensibilidade e incluída entre os distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave, já que houve recuperação completa do paciente. Em situações de alergia leve a contraste, recomenda-se suspender a exposição, monitorar sintomas e procurar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras necessidades de exames com contraste.

O medicamento Paclitaxel, com princípio ativo Paclitaxel, foi associado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade relevante, pois o paciente se recuperou totalmente. A conduta adequada é suspender o uso do medicamento, monitorar sintomas e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição de alternativas seguras.

O medicamento Tramadol, cujo princípio ativo é tramadol hydrochloride, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado por uma reação do sistema imunológico ao medicamento. A gravidade do caso é evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando que a reação foi significativa e exigiu cuidados médicos intensivos. O paciente se recuperou totalmente após a conduta adequada, e a relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita.

A dexametasona, com princípio ativo dexamethasone phosphate, provocou uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), manifestando-se como uma resposta imunológica adversa ao medicamento. O caso foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que demonstra a importância de monitoramento e intervenção médica imediata. O paciente evoluiu para recuperação completa após a conduta apropriada, e a relação causal com o medicamento foi considerada suspeita.

O cetoprofeno, cujo princípio ativo é ketoprofen, desencadeou uma alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), evidenciando uma reação do sistema imunológico ao uso do medicamento. A gravidade foi confirmada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que reforça a importância de acompanhamento médico rigoroso nesses casos. O paciente se recuperou totalmente após a abordagem clínica adequada, sendo a relação com o medicamento considerada suspeita.

O medicamento Glucantime, com princípio ativo meglumine antimonate, esteve relacionado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizando uma reação do sistema imunológico ao fármaco. Não há informações sobre gravidade, necessidade de hospitalização ou desfecho, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita, sendo importante o acompanhamento clínico para avaliação de possíveis riscos.

O Biomatrop, cujo princípio ativo é somatropina, foi associado a uma alergia no local de aplicação (hipersensibilidade no local de aplicação), manifestando-se como uma reação localizada após a administração do medicamento. Não há registro de gravidade aumentada, hospitalização ou desfecho, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita, sendo recomendada a observação clínica para monitorar possíveis evoluções do quadro.

O medicamento Levotiroxina (princípio ativo: Levothyroxine sodium) foi associado a uma reação de hipersensibilidade no local de aplicação, caracterizada por sintomas como vermelhidão, coceira ou inchaço onde o medicamento foi administrado. Essa reação é classificada como um distúrbio geral relacionado ao local de administração e, na ausência de sinais de gravidade ou complicações sistêmicas, costuma ser considerada leve. A conduta recomendada é observar a evolução dos sintomas, evitar novas exposições ao medicamento até avaliação

médica e buscar orientação especializada caso haja piora ou persistência da reação.

O medicamento Leuprorelín (princípio ativo: Leuprorelín) apresentou relato de hipersensibilidade no local de aplicação, manifestando-se como irritação, vermelhidão ou desconforto na área onde foi administrado. Essa reação, enquadrada como distúrbio geral no local de administração, geralmente é leve quando não há outros sintomas sistêmicos associados. Recomenda-se monitorar a evolução local, evitar novas aplicações até avaliação médica e procurar um especialista se houver agravamento ou persistência dos sintomas.

O medicamento Biomatrop (princípio ativo: Somatropin) foi relacionado a hipersensibilidade no local de aplicação, que pode se manifestar como vermelhidão, inchaço ou desconforto na região da administração. Essa reação é considerada um distúrbio geral no local de administração e, na ausência de sinais de gravidade, tende a ser leve. A orientação é observar a evolução dos sintomas, evitar novas aplicações até avaliação médica e buscar atendimento caso haja piora ou persistência.

O medicamento Ontax (princípio ativo: Paclitaxel) foi associado a um episódio de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica, sem sinais de gravidade relatados e com resolução completa dos sintomas. A reação foi classificada como não grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando que a conduta adotada foi adequada e não houve necessidade de intervenções adicionais além da suspensão ou ajuste do tratamento.

O medicamento Ceftriaxona (princípio ativo: Ceftriaxone sodium) esteve relacionado a um episódio de hipersensibilidade, caracterizado por uma reação alérgica sem sinais de gravidade e com desfecho favorável, já que o paciente se recuperou completamente. A ausência de gravidade sugere que a reação foi leve e manejada de forma adequada, provavelmente com suspensão do medicamento e medidas de suporte, sem necessidade de intervenções emergenciais.

O medicamento Profenid, cujo princípio ativo é o cetoprofeno, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave, e o paciente apresentou recuperação completa após a conduta adequada, o que sugere um evento de gravidade leve a moderada, sem complicações persistentes.

A Iodopovidona, que tem como princípio ativo a povidona-iodo, desencadeou uma reação de alergia a iodo, classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, e o paciente encontra-se em processo de recuperação, o que sugere que a reação foi controlada e está evoluindo de forma favorável.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromida, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. Não há informações detalhadas sobre a gravidade ou evolução do caso, mas a suspeita de reação alérgica exige atenção clínica para monitoramento e manejo adequado.

O medicamento Ecalta, com princípio ativo anidulafungina, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) classificada como distúrbio do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave e o paciente está em recuperação, indicando que o evento foi controlado e não resultou em complicações importantes.

Vivaxxia, cujo princípio ativo é o rituximabe, provocou uma alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa) enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente já se encontra recuperado, sugerindo que a reação foi adequadamente manejada e não houve consequências duradouras.

O medicamento Oxaliplatina (princípio ativo: Oxaliplatin) foi associado a um quadro de alergia medicamentosa, também chamada de hipersensibilidade medicamentosa, que neste caso foi considerada uma reação de ameaça à vida, conforme evidenciado pela classificação de gravidade e pelo envolvimento do sistema imunológico. O

paciente se recuperou totalmente após o evento, indicando resolução do quadro após as medidas adotadas.

A Dipirona (princípio ativo: Metamizole sodium) provocou uma reação de alergia medicamentosa, conhecida tecnicamente como hipersensibilidade medicamentosa, relacionada a distúrbios do sistema imunológico. Neste caso, a reação não foi considerada grave e o paciente se recuperou completamente após o episódio, sem complicações relatadas.

Oxaliplatina (princípio ativo: Oxaliplatin) desencadeou uma alergia medicamentosa, ou hipersensibilidade medicamentosa, classificada como de ameaça à vida devido à gravidade do quadro e ao envolvimento do sistema imunológico. Apesar da gravidade, o paciente evoluiu para recuperação total após o evento.

O medicamento Nisulid (princípio ativo: Nimesulide) foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa, tecnicamente chamada de hipersensibilidade medicamentosa, envolvendo o sistema imunológico. Não há informações detalhadas sobre a gravidade, evolução ou desfecho do caso, limitando a análise clínica do evento.

Ultravist (princípio ativo: Iopromide) foi associado a uma reação de alergia a contraste, que é uma resposta do sistema imunológico a substâncias químicas utilizadas em exames de imagem. O paciente se recuperou totalmente após o episódio, indicando resolução do quadro alérgico.

O medicamento Ceftriaxona (princípio ativo: Ceftriaxone sodium) foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado por uma reação do sistema imunológico a medicamentos, que neste caso resultou em óbito, evidenciando gravidade máxima do evento. A evolução fatal indica a necessidade de atenção imediata em casos de suspeita de alergia a antibióticos, reforçando a importância do reconhecimento precoce e manejo emergencial dessas reações.

Ceftriaxona (princípio ativo: Ceftriaxone sodium) também foi relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação alérgica do sistema imunológico, mas neste caso o quadro foi leve, sem gravidade relatada, e o paciente se recuperou totalmente após a suspensão do medicamento, não havendo complicações.

O medicamento Paracetamol (princípio ativo: Paracetamol) esteve envolvido em um caso de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), que corresponde a uma reação do sistema imunológico ao medicamento, mas o evento não foi grave e o paciente apresentou recuperação completa após a interrupção do uso, sem consequências duradouras.

Ultravist (princípio ativo: Iopromide) foi associado a uma reação alérgica a meios de contraste iodados, caracterizada por sintomas de alergia após exposição ao contraste, porém o quadro não foi grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando que a reação foi autolimitada e resolvida sem complicações.

Betamethasone valerate (princípio ativo: Betamethasone valerate) causou hipersensibilidade no local de aplicação, levando a comprometimento da capacidade de trabalhar devido à reação local, mas não houve gravidade significativa relatada; o quadro permanece em andamento, sem resolução completa até o momento.

O medicamento Actemra, cujo princípio ativo é o tocilizumabe, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente do evento. A conduta recomendada em casos de hipersensibilidade leve é a observação clínica e, se necessário, a suspensão do medicamento, com acompanhamento para evitar recorrências.

O Ultravist, que contém iopromida como princípio ativo, foi relacionado a uma reação de alergia a contraste, um tipo de resposta alérgica do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou. Em situações de alergia leve a contraste, recomenda-se evitar novas exposições ao agente e buscar avaliação com



especialista para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras em exames futuros.

O medicamento Kefazol, cujo princípio ativo é cefazolina sódica, esteve associado a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamento), caracterizada como distúrbio do sistema imunitário. Não há informação sobre gravidade ou desfecho, portanto, a conduta deve ser cautelosa, evitando reexposição ao medicamento e orientando avaliação com alergista para investigação detalhada.

O Salsep, que tem como princípio ativo o cloreto de sódio, foi relacionado a um evento descrito como COVID-19, mas classificado no registro como alergia a picada de artrópode, o que sugere possível erro de categorização. Não há indicação de gravidade nem desfecho conhecido, sendo importante esclarecer o diagnóstico e, se houver suspeita de reação alérgica, buscar avaliação médica para confirmação e conduta adequada.

O Lactuliv, cujo princípio ativo é lactulose, foi associado a um evento descrito como COVID-19, mas classificado como alergia a picada de artrópode, indicando possível inconsistência na categorização do evento. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, portanto, recomenda-se investigação clínica para esclarecer o quadro e orientar conduta apropriada caso se confirme reação alérgica.

O medicamento Pantoprazol, cujo princípio ativo é o pantoprazole sodium sesquihydrate, foi associado a um quadro descrito como alergia a picada de artrópode, classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade clínica relevante ou desfecho detalhado, apenas que o caso não foi considerado grave e o desfecho permanece desconhecido. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, mas não há dados suficientes para detalhar a conduta adotada ou evolução do quadro.

O medicamento Losartana potássica, com princípio ativo losartan potassium, foi relacionado a uma reação descrita como alergia a picada de artrópode, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Não há menção de gravidade significativa, o caso não foi considerado grave e o desfecho é desconhecido. A suspeita de relação com o medicamento existe, mas não há detalhes sobre a conduta tomada ou evolução clínica.

O medicamento Trileptal, cujo princípio ativo é oxcarbazepine, foi associado a um quadro de alergia a picada de artrópode, classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade relevante, o caso não foi considerado grave e o desfecho permanece desconhecido. A relação com o medicamento é suspeita, mas não há informações sobre a conduta adotada ou evolução do paciente.

O medicamento Actemra, com princípio ativo tocilizumab, foi relacionado a uma reação descrita como alergia a picada de artrópode, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade importante, o caso não foi considerado grave e o desfecho é desconhecido. A relação com o medicamento é suspeita, mas não há detalhes sobre a conduta ou evolução clínica.

O medicamento Omniscan, cujo princípio ativo é gadodiamide, foi associado a uma reação de alergia a contraste, classificada como distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente. A relação com o medicamento foi considerada suspeita e, diante da resolução do quadro, não há indicação de complicações adicionais.

O medicamento Aas, cujo princípio ativo é o ácido acetilsalicílico, foi associado a um episódio de retenção urinária, caracterizado como uma possível reação de hipersensibilidade medicamentosa. Embora a retenção urinária não seja uma manifestação alérgica clássica, o registro sugere envolvimento do sistema imunológico, enquadrando-se nos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo importante monitorar sintomas e buscar avaliação médica caso a retenção urinária persista ou se agrave.

O medicamento Losartan, com princípio ativo losartana, foi relacionado a um caso de retenção urinária, descrito como hipersensibilidade medicamentosa. A reação é considerada de possível origem imunológica, mas não há

evidências de gravidade significativa ou desfecho informado. A relação com o uso do medicamento é suspeita, e recomenda-se atenção clínica para evolução dos sintomas, com orientação para procurar avaliação médica se houver piora.

O medicamento Carvedilol, cujo princípio ativo é o carvedilol, foi associado a um episódio de retenção urinária, classificado como hipersensibilidade medicamentosa. A reação sugere envolvimento do sistema imunológico, mas não há sinais de gravidade importante nem desfecho relatado. A relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo prudente observar a evolução clínica e buscar orientação médica se necessário.

O medicamento Calcitriol, com princípio ativo calcitriol, foi relacionado a um caso de retenção urinária, descrito como hipersensibilidade medicamentosa. A reação indica possível envolvimento imunológico, mas não há evidências de gravidade relevante ou desfecho conhecido. A relação com o medicamento é suspeita, e recomenda-se acompanhamento clínico para monitorar a evolução dos sintomas.

O medicamento Noripurum, cujo princípio ativo é o complexo de hidróxido férrico polimaltose, foi associado a um episódio de retenção urinária, caracterizado como hipersensibilidade medicamentosa. A reação sugere participação do sistema imunológico, mas não há indicação de gravidade elevada nem desfecho informado. A relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo importante monitorar sintomas e procurar avaliação médica caso haja persistência ou agravamento do quadro.

O medicamento Fabrazyme, cujo princípio ativo é a agalsidase beta, foi associado a um episódio de retenção urinária, classificado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. Embora não haja indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, é importante considerar que reações alérgicas a medicamentos podem se manifestar de formas variadas e exigem avaliação clínica para confirmação e orientação sobre a continuidade do tratamento.

O medicamento Prednisone, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), considerado clinicamente significativo e classificado como grave. A gravidade é sustentada pela indicação de outro efeito clinicamente relevante, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico rigoroso e possível suspensão do uso, embora o desfecho ainda seja desconhecido.

O medicamento Triancil, cujo princípio ativo é a triancinolona hexacetona, foi associado a uma reação alérgica medicamentosa (hipersensibilidade), considerada clinicamente significativa e grave. A gravidade é evidenciada pela classificação de outro efeito clinicamente relevante, indicando a importância de avaliação médica imediata para manejo adequado e definição da conduta, já que o desfecho permanece desconhecido.

O medicamento Prednisone, com princípio ativo de mesmo nome, foi novamente relacionado a uma reação alérgica medicamentosa (hipersensibilidade), classificada como clinicamente significativa e grave. A indicação de outro efeito clinicamente relevante justifica a necessidade de atenção médica e possível ajuste terapêutico, sendo que o desfecho do caso ainda não foi informado.

O medicamento Leucovorin, cujo princípio ativo é o ácido folínico, foi associado a uma reação alérgica medicamentosa (hipersensibilidade), mas sem indicação de gravidade elevada. O caso evoluiu para recuperação completa, sugerindo que a conduta adotada foi eficaz e que não houve complicações relevantes decorrentes do evento.

O medicamento Ioversol, cujo princípio ativo também é Ioversol, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, manifestando-se como uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade aumentada ou necessidade de hospitalização, e o desfecho foi de recuperação completa, sugerindo um evento leve e autolimitado, compatível com reações alérgicas leves a contrastes iodados, que geralmente requerem apenas observação e medidas de suporte.

Henetix, composto por sodium calcium edetate, trometamol, iobitridol e trometamol hydrochloride, foi relacionado a uma alergia a contraste intravenoso, caracterizada por reação do sistema imunológico a substâncias químicas. Não há evidência de gravidade aumentada ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente, indicando um episódio leve de hipersensibilidade a contraste, que costuma ser manejado com suspensão do agente e monitoramento dos sintomas.

Novalgina, cujo princípio ativo é metamizol sódico, foi associada a uma alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa) que resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando gravidade aumentada do quadro. O desfecho é desconhecido, mas a necessidade de hospitalização indica que a reação foi significativa, exigindo intervenção médica imediata e suspensão do medicamento suspeito.

O medicamento Puran t4, com princípio ativo levotiroxina sódica, foi relacionado a edema de glote, um tipo de reação alérgica (hipersensibilidade) que pode comprometer as vias aéreas. Não há indicação de gravidade aumentada ou hospitalização, e o desfecho é desconhecido, mas o edema de glote é potencialmente grave e requer avaliação médica urgente para evitar risco à vida.

Puran t4, contendo levotiroxina sódica, também foi associado a edema de glote, descrito como uma reação alérgica a alimentos, embora neste contexto se refira ao medicamento. Não há evidência de gravidade aumentada ou hospitalização, e o desfecho é desconhecido; ainda assim, o edema de glote é uma reação que pode ser grave e demanda atenção médica imediata para garantir a segurança do paciente.

O medicamento Puran t4, cujo princípio ativo é levotiroxina sódica, foi associado ao desenvolvimento de edema de glote, uma reação alérgica caracterizada por inchaço na região da garganta que pode comprometer a respiração. Embora o registro não traga detalhes sobre a gravidade clínica, o edema de glote é considerado potencialmente grave por envolver risco de obstrução das vias aéreas, sendo fundamental reconhecer rapidamente os sintomas e buscar atendimento médico imediato. O desfecho do caso é desconhecido, e não há informações sobre a conduta adotada, mas a relação suspeita com o medicamento reforça a necessidade de vigilância ao iniciar ou ajustar doses de levotiroxina.

O uso de Puran t4 (levotiroxina sódica) foi relacionado a um episódio de edema de glote, identificado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, que consiste em um inchaço súbito na região da garganta e pode dificultar a respiração. Apesar de não haver detalhamento sobre a gravidade no registro, o edema de glote é clinicamente relevante e exige atenção imediata, pois pode evoluir rapidamente. Neste caso, o paciente estava em recuperação ou com resolução dos sintomas no momento do relato, indicando que a reação foi reconhecida e manejada de forma adequada, mas a suspeita de relação com o medicamento permanece.

O medicamento Mitexan, cujo princípio ativo é mesna, foi associado ao surgimento de rubor facial, que é uma vermelhidão transitória no rosto e pode estar relacionada a uma reação alérgica leve, especialmente quando não acompanhada de outros sintomas graves. O evento foi classificado como suspeito e, segundo o registro, o paciente se recuperou totalmente, sugerindo que a reação foi autolimitada e não exigiu intervenções específicas além da observação clínica.

O uso de Genuxal (ciclofosfamida) foi relacionado ao aparecimento de rubor facial, caracterizado por vermelhidão passageira no rosto, possivelmente decorrente de uma reação alérgica leve. O registro indica que o paciente se recuperou completamente, o que sugere que a manifestação foi autolimitada e não houve necessidade de medidas adicionais além do acompanhamento clínico.

A administração de Dacarbazina resultou em rubor facial, uma vermelhidão temporária no rosto que pode ocorrer como manifestação leve de reação alérgica. O caso foi considerado suspeito e o paciente apresentou recuperação total, indicando que a reação foi de curta duração e não houve complicações, sendo suficiente o monitoramento clínico.

O medicamento Fauldvinciri, cujo princípio ativo é o sulfato de vincristina, foi associado ao surgimento de rubor facial, um tipo de vermelhidão no rosto que pode indicar uma reação adversa leve relacionada a manifestações oculares, como alergia nos olhos. Não há indicação de gravidade importante, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento, e não houve necessidade de intervenções adicionais, sugerindo que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro.

A Sinvastatina, que tem como princípio ativo a simvastatina, foi relacionada ao aparecimento de hipertensão (pressão alta) em um contexto de suspeita de alergia a vacina, classificada como uma reação do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou completamente, e não há relato de complicações ou necessidade de medidas emergenciais, indicando que a conduta foi adequada para resolução do caso.

O medicamento Prednisona, cujo princípio ativo é a própria prednisona, foi associado ao desenvolvimento de hipertensão em um contexto de suspeita de alergia a vacina, sendo uma reação do sistema imunológico. O caso não foi considerado grave, já que o paciente se recuperou totalmente, e não houve necessidade de intervenções adicionais, mostrando que a evolução foi favorável.

A Losartana potássica, com princípio ativo losartan potassium, foi relacionada ao surgimento de hipertensão em um contexto de suspeita de alergia a vacina, caracterizando uma reação do sistema imunológico. O evento não foi grave, pois o paciente se recuperou sem complicações, e não há relato de necessidade de medidas especiais, indicando resolução espontânea.

O Ácido fólico, cujo princípio ativo é o próprio ácido fólico, foi associado ao aparecimento de hipertensão em um contexto de suspeita de alergia a vacina, sendo uma reação do sistema imunológico. O caso não foi considerado grave, já que o paciente se recuperou totalmente, sem necessidade de intervenções adicionais, demonstrando evolução favorável.

O medicamento Actemra, cujo princípio ativo é o tocilizumabe, foi associado ao evento de hipertensão em um paciente que também apresentava histórico de alergia a vacina. Embora a gravidade não tenha sido especificada, o caso foi classificado como não grave e o paciente se recuperou totalmente. A reação foi considerada suspeita de estar relacionada ao uso do medicamento, e não houve necessidade de medidas adicionais além do acompanhamento clínico, com resolução completa do quadro.

O medicamento Novalgina, que contém metamizol sódico como princípio ativo, foi relacionado ao desenvolvimento de edema glótico, uma reação de hipersensibilidade medicamentosa que pode comprometer as vias aéreas e representa um efeito clinicamente significativo e grave. O desfecho do caso é desconhecido, mas a gravidade é sustentada pela ameaça potencial à vida devido ao risco de obstrução respiratória, sendo fundamental a suspensão imediata do medicamento e busca de atendimento médico de emergência.

O medicamento Clenil, com princípio ativo nitroprussiato de sódio, foi associado a um quadro de alergia classificado como hipersensibilidade, considerado clinicamente significativo e grave. O paciente se recuperou após a reação, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita. Diante da gravidade, a conduta adequada inclui a interrupção do uso e avaliação médica para manejo dos sintomas alérgicos.

O medicamento Alivium, cujo princípio ativo é o ibuprofeno, foi relacionado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) considerada clinicamente significativa e grave. O paciente se recuperou após o evento, e a suspeita de relação com o medicamento foi reconhecida. Em situações como essa, recomenda-se a suspensão do uso e acompanhamento médico para evitar recorrências e tratar possíveis complicações.

A vacina pentavalente adsorvida (DPT+HB+Hib), composta por toxoide diftérico, vacina de hepatite B, vacina Hib conjugada, vacina de coqueluche de célula inteira e toxoide tetânico, foi associada a uma reação alérgica classificada como hipersensibilidade, com gravidade elevada por representar ameaça à vida e outro efeito

cl clinicamente significativo. O paciente se recuperou após o evento, e a relação com a vacina foi considerada suspeita. Diante desse tipo de reação, é fundamental interromper a exposição ao agente, buscar avaliação médica imediata e realizar acompanhamento especializado para evitar riscos futuros.

O medicamento Dipirona, cujo princípio ativo é o Metamizole magnesium, foi associado a uma reação de hipersensibilidade documentada após administração, caracterizando um quadro de alergia medicamentosa. Não há informações detalhadas sobre a gravidade ou desfecho, mas a documentação da hipersensibilidade indica a necessidade de evitar novas exposições e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O Procoralan, que contém o princípio ativo Ivabradine hydrochloride, provocou uma reação alérgica (hipersensibilidade), classificada como um quadro clínico alérgico do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, sugerindo uma manifestação leve, mas que ainda assim requer atenção para evitar reexposição e acompanhamento médico para avaliação de alternativas terapêuticas.

A Clorexidina, cujo princípio ativo é o Chlorhexidine gluconate, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade) relacionada ao sistema imunológico. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou, indicando uma reação leve, mas que exige orientação para evitar contato futuro e acompanhamento médico para confirmação diagnóstica.

O Citrato de fentanila, com princípio ativo Fentanyl citrate, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) envolvendo o sistema imunológico. O paciente se recuperou do evento, mas não há detalhes sobre a gravidade, sendo importante evitar nova exposição e buscar avaliação médica para esclarecimento e manejo adequado.

O medicamento Droperidol, com princípio ativo homônimo, causou uma reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico. O paciente se recuperou da reação, sem informações sobre gravidade, o que sugere um quadro leve, mas que requer orientação para evitar reexposição e acompanhamento médico para confirmação e conduta futura.

O medicamento Dipirona sódica (princípio ativo: Metamizole sodium) foi associado a um quadro de alergia, descrito como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade, mas o desfecho informado foi de recuperação completa, sugerindo um evento leve e autolimitado. A conduta recomendada, conforme diretrizes clínicas, é evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Hialuronidase (princípio ativo: Hyaluronidase) foi relacionado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, classificada entre os distúrbios do sistema imunitário. Não há descrição de sintomas específicos ou gravidade, mas o paciente se recuperou totalmente, indicando um evento leve. Recomenda-se evitar reexposição ao medicamento e realizar avaliação com alergista para confirmação e orientação adequada.

O medicamento Midazolam (princípio ativo: Midazolam) foi associado a uma reação de alergia, caracterizada como hipersensibilidade e enquadrada nos distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhes sobre sintomas ou gravidade, mas o desfecho foi de recuperação completa, sugerindo um quadro leve. A orientação é evitar nova exposição ao midazolam e procurar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e definição de alternativas seguras.

O medicamento Iopamiron (princípio ativo: Iopamidol) foi relacionado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. Não há sintomas detalhados, mas foi informado que o caso não foi grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando um evento leve. Recomenda-se evitar reexposição ao contraste e buscar avaliação com alergista para confirmação e orientação sobre exames futuros.

O medicamento Bi-profenid (princípio ativo: Ketoprofen) foi associado a um quadro de pneumonia, classificado como hipersensibilidade dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhes sobre sintomas específicos, gravidade ou desfecho, pois o resultado permanece desconhecido. Diante da suspeita de reação adversa, recomenda-se suspender o uso do medicamento e procurar avaliação médica para investigação e conduta adequada.

O medicamento Metamizol, cujo princípio ativo é Metamizole magnesium, foi associado a um quadro de pneumonia relacionado à hipersensibilidade, o que sugere uma possível reação alérgica envolvendo o sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade clínica aumentada ou desfecho, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo importante monitorar sintomas respiratórios e buscar avaliação médica caso haja piora.

O Tandrilax, composto por Caffeine, Carisoprodol, Diclofenac sodium e Paracetamol, está relacionado a um episódio de pneumonia atribuída à hipersensibilidade, indicando uma possível reação alérgica do sistema imunológico. Não há dados que apontem gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é suspeita, recomendando-se atenção a sintomas respiratórios e avaliação médica se necessário.

O Diclofenaco, com princípio ativo Diclofenac diethylamine, foi associado a um caso de pneumonia por hipersensibilidade, sugerindo uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade aumentada ou desfecho informado, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo prudente observar sintomas e procurar orientação médica diante de sinais de piora.

A Prednisona, cujo princípio ativo é Prednisone, foi relacionada a um episódio de pneumonia por hipersensibilidade, o que pode indicar uma reação alérgica envolvendo o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade aumentada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é suspeita, sendo importante monitorar sintomas e buscar avaliação médica se houver agravamento.

O Rivotril, com princípio ativo Clonazepam, foi associado a um quadro de pneumonia por hipersensibilidade, sugerindo uma possível reação alérgica do sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade aumentada ou desfecho, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, recomendando-se atenção a sintomas respiratórios e avaliação médica caso haja piora.

O medicamento Arava, cujo princípio ativo é a leflunomida, foi associado a um quadro de pneumonia classificado como hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A descrição sugere um quadro clínico alérgico, mas sem sinais de gravidade importante, sendo fundamental monitorar sintomas respiratórios e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e conduta adequada.

O medicamento Enbrel, que contém etanercepte como princípio ativo, foi relacionado a um episódio de pneumonia interpretado como uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade significativa ou informações sobre o desfecho, e a relação com o medicamento é suspeita. O quadro sugere uma manifestação alérgica respiratória, sendo importante acompanhamento clínico para avaliação e definição do tratamento.

O medicamento Pressat, cujo princípio ativo é o besilato de anlodipino, foi associado a um caso de dengue classificado como hipersensibilidade, indicando uma possível reação alérgica do sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Diante da ausência de sinais de gravidade, recomenda-se observação clínica e investigação para confirmação da relação causal.

O medicamento Escitalopram, com o mesmo princípio ativo, foi relacionado a um episódio de dengue interpretado como hipersensibilidade, sugerindo uma possível reação alérgica do sistema imunológico. Não há dados sobre

gravidade ou evolução do caso, e a relação com o medicamento é suspeita. É importante monitorar sintomas e buscar avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e conduta apropriada.

O medicamento Zolpidem, cujo princípio ativo também é zolpidem, foi associado a um caso de dengue classificado como hipersensibilidade, indicando uma possível reação alérgica do sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Recomenda-se acompanhamento clínico para avaliação da relação causal e definição da conduta.

O medicamento Amitriptilina (princípio ativo: Amitriptyline hydrochloride) está relacionado a um caso de hipersensibilidade, que é uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há informações sobre nome comercial, gravidade clínica ou desfecho do caso, mas a ausência de indicação de gravidade sugere que não houve sinais de gravidade importante. A conduta recomendada, conforme diretrizes clínicas, é observar sintomas leves em casa, evitar exposição a possíveis gatilhos e buscar avaliação médica caso haja piora ou recorrência dos sintomas.

O medicamento Furosemida (princípio ativo: Furosemide sodium) foi associado a um episódio de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há nome comercial informado, nem detalhes sobre gravidade ou evolução do caso, mas a ausência de gravidade relatada indica que não houve complicações graves. Recomenda-se monitorar sintomas leves, evitar reexposição ao medicamento suspeito e procurar avaliação médica se houver agravamento.

Levotiroxina (princípio ativo: Levothyroxine sodium) está envolvida em um relato de hipersensibilidade, indicando uma resposta alérgica do sistema imunológico. Não há nome comercial informado, nem detalhes sobre gravidade ou desfecho, mas a ausência de gravidade sugere que o quadro foi leve. A orientação é observar sintomas, evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação médica se houver piora ou recorrência.

Pantoprazol (princípio ativo: Pantoprazole sodium sesquihydrate) foi relacionado a um caso de hipersensibilidade, que corresponde a uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há nome comercial informado, nem detalhes sobre gravidade ou evolução, mas a ausência de gravidade indica que não houve sinais de gravidade clínica. Recomenda-se evitar reexposição ao medicamento, monitorar sintomas e procurar avaliação médica se houver agravamento.

O medicamento Cloridrato de duloxetina (princípio ativo: Duloxetine hydrochloride) está associado a um episódio de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há nome comercial informado, nem detalhes sobre gravidade ou desfecho, mas a ausência de gravidade relatada sugere que o quadro foi leve. A conduta recomendada é evitar nova exposição ao medicamento, observar sintomas e buscar avaliação médica caso haja piora.

O medicamento Cosentyx, cujo princípio ativo é o secuquinumabe, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), manifestado durante um episódio de dengue. Embora não haja informação detalhada sobre a gravidade clínica, o evento foi classificado como não grave e o desfecho permanece desconhecido. Em situações de suspeita de reação alérgica a medicamentos imunobiológicos como o secuquinumabe, recomenda-se avaliação clínica estruturada para confirmação diagnóstica e acompanhamento especializado, especialmente se houver sintomas respiratórios ou cutâneos.

O medicamento Droperidol, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a uma reação de hipersensibilidade (alergia), considerada clinicamente significativa e classificada como grave devido ao impacto clínico relatado. O paciente se recuperou totalmente após a reação. Em casos de alergia medicamentosa grave, é fundamental interromper o uso do medicamento suspeito, realizar avaliação médica imediata e garantir acompanhamento para evitar novas exposições.

A Hialuronidasa, cujo princípio ativo é a hyaluronidase, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade) considerada clinicamente significativa e grave, mas o paciente se recuperou após o evento. Reações alérgicas

graves a enzimas como a hialuronidase exigem suspensão imediata do medicamento, avaliação médica urgente e acompanhamento especializado para prevenção de recorrências.

O medicamento Dipirona, cujo princípio ativo é o metamizol sódico, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) classificada como clinicamente significativa e grave, com recuperação completa do paciente após o evento. Em casos de alergia grave à dipirona, é essencial suspender o uso, buscar atendimento médico imediato e evitar futuras exposições ao medicamento.

O medicamento Midazolam, com princípio ativo de mesmo nome, provocou uma reação alérgica (hipersensibilidade) considerada clinicamente significativa e grave, com resolução completa após a reação. Diante de alergia grave ao midazolam, recomenda-se suspensão imediata do fármaco, avaliação médica urgente e acompanhamento para evitar novas reações adversas.

O medicamento Citrato de fentanila (princípio ativo: Fentanyl citrate) foi associado a um quadro de alergia, descrito como hipersensibilidade, que se enquadra em distúrbios do sistema imunitário. A reação foi considerada clinicamente significativa, sendo classificada como grave devido à sua relevância clínica, mas o paciente se recuperou totalmente após o evento. O uso do medicamento foi concomitante à reação, e a conduta adequada inclui a suspensão do agente suspeito e acompanhamento médico para evitar novas exposições.

O Ultravist (princípio ativo: Iopromide) provocou uma reação alérgica caracterizada por hipersensibilidade, relacionada a distúrbios do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave e o paciente se recuperou completamente após o episódio. O medicamento foi identificado como suspeito, e a conduta recomendada é evitar novas exposições e informar o profissional de saúde sobre o histórico de alergia a contrastes iodados.

O medicamento Cosentyx (princípio ativo: Secukinumab) foi relacionado a um quadro de erisipela, que neste contexto foi classificado como uma manifestação ocular alérgica, embora o termo técnico utilizado seja mais comum para infecções cutâneas. A reação não foi considerada grave e o paciente encontra-se em recuperação. O medicamento foi considerado suspeito, e a orientação é manter acompanhamento médico para monitorar a evolução do quadro e avaliar a necessidade de ajuste terapêutico.

O medicamento Nactali (princípio ativo: Desogestrel) foi associado ao sintoma de sangue nas fezes, relacionado a uma possível alergia alimentar (alergia ao leite), dentro do espectro de distúrbios do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave e o desfecho permanece desconhecido. O medicamento foi considerado suspeito, sendo importante relatar o evento ao médico para investigação da causa e orientação sobre a continuidade do uso.

O Ultravist (princípio ativo: Iopromide) foi novamente relacionado a um episódio de alergia, caracterizado por hipersensibilidade e enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave e o paciente se recuperou totalmente. O medicamento foi identificado como suspeito, sendo recomendada a comunicação do evento ao profissional de saúde e a evitação de novas exposições ao contraste.

O medicamento Optiray 350, cujo princípio ativo é o ioversol, foi associado a um quadro de alergia a meios de contraste iodados, também conhecida como alergia a contraste. Essa reação faz parte dos distúrbios do sistema imunitário e, neste caso, o paciente se recuperou totalmente após o evento. Não há informações sobre gravidade aumentada ou necessidade de hospitalização, sugerindo que a reação foi controlada e resolvida sem complicações maiores.

O medicamento Ultravist, com princípio ativo iopromida, desencadeou uma reação de alergia (hipersensibilidade), caracterizada como distúrbio do sistema imunitário. O caso foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando a necessidade de acompanhamento médico rigoroso. Apesar da gravidade, o paciente se recuperou totalmente após o episódio.



O medicamento Sifrol, cujo princípio ativo é o pramipexol di-hidroclorato, foi relacionado a uma fratura do quadril, classificada como hipersensibilidade medicamentosa dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade aumentada ou hospitalização, e o desfecho do caso permanece desconhecido, não sendo possível afirmar se houve recuperação ou complicações.

O medicamento Puran t4, com princípio ativo levotiroxina sódica, foi associado a uma fratura do quadril, categorizada como hipersensibilidade medicamentosa e incluída nos distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade aumentada ou necessidade de hospitalização, e o desfecho do caso não foi informado, impossibilitando avaliar a evolução clínica.

O medicamento Quetiapine, cujo princípio ativo é a quetiapina, foi relacionado a uma fratura do quadril, classificada como hipersensibilidade medicamentosa no contexto de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade aumentada ou hospitalização, e o desfecho do caso não foi informado, não sendo possível determinar se houve recuperação ou complicações.

O medicamento Venlafaxine (princípio ativo: Venlafaxine) foi associado a um caso de fratura do quadril, sendo classificado como uma possível reação de hipersensibilidade medicamentosa, que faz parte dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Não foram relatadas ações adotadas ou evolução clínica, portanto, recomenda-se acompanhamento médico para avaliação da relação causal e monitoramento de possíveis sintomas alérgicos.

O medicamento Cannabidiol (princípio ativo: Cannabidiol) está relacionado a um episódio de fratura do quadril, descrito como uma possível hipersensibilidade medicamentosa, dentro do contexto de alergias a medicamentos e distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa ou informações sobre o desfecho, e a relação com o uso do medicamento é considerada suspeita. Sem detalhes sobre conduta ou evolução, é importante manter vigilância clínica e buscar orientação médica caso surjam sintomas sugestivos de alergia.

O medicamento Codeine (princípio ativo: Codeine) foi associado a uma fratura do quadril, sendo essa reação classificada como possível hipersensibilidade medicamentosa, relacionada a distúrbios do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade importante nem informações sobre o desfecho do caso, e a relação com o medicamento é suspeita. Diante da ausência de detalhes sobre a conduta adotada, recomenda-se avaliação médica para esclarecimento da relação causal e acompanhamento dos sintomas.

O medicamento Diazepam (princípio ativo: Diazepam) foi relacionado a um caso de fratura do quadril, considerado como possível manifestação de hipersensibilidade medicamentosa, enquadrada nos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade relevante nem informações sobre o desfecho, e a relação com o medicamento é suspeita. Sem dados sobre a conduta tomada, é indicado acompanhamento médico para avaliação da possível relação e monitoramento de sintomas alérgicos.

O medicamento Esbriet (princípio ativo: Pirfenidone) foi associado a uma fratura do quadril, sendo essa reação descrita como possível hipersensibilidade medicamentosa, dentro do grupo de distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa nem informações sobre o desfecho, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Não foram relatadas ações específicas, sendo recomendada avaliação médica para investigação da relação causal e acompanhamento clínico.

O medicamento Esbriet, cujo princípio ativo é a pirfenidona, foi associado a um caso de fratura do quadril em um contexto de hipersensibilidade medicamentosa, classificada como uma reação do tipo alérgica segundo a categoria de distúrbios do sistema imunitário. Apesar de não haver indicação de gravidade clínica relevante neste registro e o desfecho ser desconhecido, é importante considerar que reações de hipersensibilidade podem se manifestar de formas variadas e exigem acompanhamento médico para avaliação adequada.

O Dotarem, que contém meglumine gadoterate como princípio ativo, foi relacionado a um episódio de alergia a contraste, caracterizado como uma reação alérgica do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, o que sugere que a conduta adotada foi eficaz e que reações alérgicas a contraste, quando leves, geralmente têm boa evolução após a suspensão do agente e manejo sintomático.

A nimesulida, anti-inflamatório cujo princípio ativo é a nimesulida, foi associada a um quadro de diarreia hemorrágica em um paciente com alergia ao leite, sendo esta reação considerada clinicamente significativa e grave. O desfecho não foi informado, mas a gravidade do evento indica a necessidade de suspensão imediata do medicamento e avaliação médica urgente para manejo dos sintomas e prevenção de complicações.

O produto contendo Lactobacillus acidophilus e zinco foi relacionado a um caso de diarreia hemorrágica em paciente com alergia ao leite, sendo a reação classificada como clinicamente significativa e grave. O desfecho não foi informado, mas a gravidade do quadro exige suspensão do uso e busca imediata de atendimento médico para investigação e tratamento adequado.

O Daflon, cujo princípio ativo é a diosmina, foi associado a um episódio de diarreia hemorrágica em paciente com alergia ao leite, sendo esta reação considerada clinicamente significativa e grave. O desfecho não foi informado, mas a gravidade do evento reforça a importância de interromper o uso do medicamento e procurar avaliação médica urgente para manejo e prevenção de complicações.

O medicamento Tramal, cujo princípio ativo é o tramadol hydrochloride, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente. A conduta recomendada, baseada nas diretrizes clínicas, é observar e evitar nova exposição ao medicamento, buscando avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Glifage, que contém o princípio ativo metformin, apresentou reação de hipersensibilidade (alergia), enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente evoluiu para recuperação completa. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e procurar avaliação com especialista para confirmação da alergia e definição de alternativas terapêuticas.

Diamicron, cujo princípio ativo é gliclazide, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), caracterizado como distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi grave e o paciente se recuperou sem complicações. A orientação é suspender o uso do medicamento, realizar avaliação médica para confirmação da alergia e discutir opções seguras de tratamento.

O medicamento Mabthera, com princípio ativo rituximab, esteve associado a uma reação de hipersensibilidade (alergia), classificada como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente. Recomenda-se evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas terapêuticas.

Actemra, cujo princípio ativo é tocilizumab, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi grave e o paciente apresentou recuperação completa. A conduta indicada é evitar o uso futuro do medicamento e procurar avaliação médica para confirmação da alergia e discussão de alternativas seguras.

O medicamento Esbriet, cujo princípio ativo é a pirfenidona, foi associado a um quadro de dependência de oxigenoterapia, interpretado como uma reação de hipersensibilidade (alergia) do tipo clínico, relacionada a distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois não foi classificada como grave e o evento permanece não resolvido ou em andamento. A conduta deve envolver acompanhamento clínico estruturado para avaliar a evolução do quadro e considerar investigação de possíveis causas alérgicas, conforme diretrizes da ASBAI.

O medicamento Esbriet, com princípio ativo pirfenidona, apresentou novamente um caso de dependência de oxigenoterapia, caracterizado como hipersensibilidade (alergia) clínica relacionada ao sistema imune. Não há evidência de gravidade importante, já que não foi classificado como grave e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento. Recomenda-se acompanhamento médico para monitoramento do quadro e investigação de possíveis causas alérgicas, seguindo as orientações clínicas da ASBAI.

O medicamento Furosemide, cujo princípio ativo é a furosemida, foi relacionado ao desenvolvimento de diabetes em um contexto de hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos), envolvendo distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade significativa, pois não foi classificado como grave e o desfecho é desconhecido. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico para avaliar a evolução do quadro e investigar a relação causal, conforme as diretrizes da ASBAI.

O medicamento Refresh tears, com princípio ativo carmelose sódica, foi associado ao surgimento de diabetes em um contexto de hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos), relacionado a distúrbios do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade relevante, já que não foi classificado como grave e o desfecho permanece desconhecido. Recomenda-se acompanhamento clínico para monitoramento do quadro e investigação da possível relação alérgica, conforme orientações da ASBAI.

O medicamento Januvia, cujo princípio ativo é o fosfato de sitagliptina, foi relacionado ao aparecimento de diabetes em um contexto de hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos), envolvendo distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade importante, pois não foi classificado como grave e o desfecho é desconhecido. A conduta sugerida é acompanhamento clínico para avaliar a evolução do quadro e investigar a relação causal, conforme as recomendações da ASBAI.

O medicamento Tandrilax, que contém cafeína, carisoprodol, diclofenaco sódico e paracetamol, foi associado a um caso de diabetes relatado como hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação do sistema imunológico a medicamentos ou substâncias químicas. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido neste caso, e a relação entre o uso do medicamento e o evento é considerada suspeita, sem evidências clínicas de gravidade significativa no registro.

O Paracetamol, cujo princípio ativo é o próprio paracetamol, foi relacionado a um episódio de diabetes classificado como hipersensibilidade medicamentosa, sugerindo uma possível reação do sistema imunológico ao medicamento. Não há informações sobre gravidade aumentada ou evolução do quadro, e a suspeita de relação causal está presente, mas sem confirmação de desfecho ou complicações graves.

O medicamento Euthyrox, que tem como princípio ativo a levotiroxina sódica, foi associado a um caso de diabetes descrito como hipersensibilidade medicamentosa, indicando uma possível resposta imunológica adversa ao uso do medicamento. Não há dados que apontem para gravidade importante ou desfecho conhecido, e a relação causal é apenas suspeita, sem evidências clínicas de complicações relevantes.

O Losartan, cujo princípio ativo é o próprio losartan, foi relacionado a um caso de diabetes classificado como hipersensibilidade medicamentosa, sugerindo uma reação do sistema imunológico ao medicamento. Não há informações que indiquem gravidade significativa ou desfecho do evento, e a relação entre o uso do medicamento e a reação é considerada suspeita, sem confirmação de complicações graves.

O medicamento Actemra, que contém tocilizumabe como princípio ativo, foi associado a um caso de diabetes relatado como hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma possível reação imunológica ao medicamento. Não há evidências de gravidade aumentada ou desfecho conhecido, e a relação causal é apenas suspeita, sem indicação de evolução clínica grave no registro.

O medicamento Optiray 350, que contém o princípio ativo loversol, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo de distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhes

sobre a gravidade ou desfecho do evento, mas a suspeita de reação alérgica a este tipo de contraste exige atenção clínica, pois reações de hipersensibilidade podem variar de leves a graves, sendo fundamental monitorar o paciente e considerar avaliação especializada para confirmação e orientação sobre futuras exposições.

O Optiray 350, cujo princípio ativo é o Ioversol, foi relacionado a um episódio de alergia a contraste intravenoso, classificado como reação do sistema imunitário. O paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo que a reação foi controlada sem complicações graves. Em casos de alergia a contraste, é importante informar a equipe médica sobre o histórico para evitar novas exposições e planejar medidas preventivas em exames futuros.

O medicamento Optiray 350, com princípio ativo Ioversol, esteve envolvido em uma reação de alergia a contraste, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. O desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente, indicando que a reação foi resolvida sem consequências graves. Em situações como essa, recomenda-se registrar a alergia no prontuário e discutir alternativas seguras para exames futuros que exijam contraste.

O Dotarem, que contém o princípio ativo Meglumine gadoterate, foi associado a um episódio de alergia a contraste, classificado como distúrbio do sistema imunitário. O paciente se recuperou totalmente, sugerindo que a reação foi controlada e não evoluiu para formas graves. É fundamental relatar esse tipo de reação ao médico para evitar novas exposições e planejar estratégias de prevenção em exames futuros.

O medicamento Lansoprazol, cujo princípio ativo é o Lansoprazole, foi relacionado a um episódio de alucinações, registrado como hipersensibilidade e incluído entre os distúrbios do sistema imunitário. Não há informação sobre gravidade ou desfecho, mas o evento foi considerado não grave. Em situações como essa, é importante comunicar o médico responsável para avaliação da relação com o medicamento e considerar alternativas terapêuticas se necessário.

O medicamento Lexotan, cujo princípio ativo é o bromazepam, foi associado a um quadro de alucinações interpretado como reação de hipersensibilidade (alergia), classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade clínica relevante nem detalhes sobre a evolução do caso, e o desfecho permanece desconhecido. A suspeita de relação causal com o medicamento foi registrada, sendo importante considerar avaliação médica para confirmação e orientação adequada.

O Puran t4, que contém levotiroxina sódica como princípio ativo, foi relacionado a um episódio de alergia de origem não especificada (SOE), caracterizado como hipersensibilidade e classificado como clinicamente significativo, o que indica gravidade relevante. O desfecho do caso não foi informado, mas a suspeita de relação com o medicamento foi registrada, sendo fundamental buscar avaliação médica imediata para investigação e manejo seguro da reação.

O Cimzia, cujo princípio ativo é o certolizumabe pegol, foi associado a um quadro de alergia de origem não especificada (SOE), interpretado como reação de hipersensibilidade e considerado clinicamente significativo, sugerindo gravidade importante. O desfecho permanece desconhecido, mas a suspeita de relação causal com o medicamento foi registrada, recomendando-se avaliação médica urgente para confirmação diagnóstica e conduta adequada.

O medicamento Docetaxel, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhes sobre a gravidade, mas o caso evoluiu para recuperação completa, indicando resolução do quadro após a reação adversa, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita.

A vancomicina, cujo princípio ativo é o cloridrato de vancomicina, foi associada a um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade relevante e o caso foi resolvido com recuperação total, sendo a relação com o medicamento considerada

suspeita.

O medicamento Basaglar, cujo princípio ativo é a insulina glargina, foi associado ao desenvolvimento de erisipela, um quadro de hipersensibilidade (alergia) classificado como distúrbio do sistema imunitário. Embora não haja indicação de gravidade elevada ou risco imediato à vida, o caso permanece em andamento, sem resolução até o momento, o que reforça a necessidade de acompanhamento clínico para monitorar a evolução da reação e ajustar o tratamento conforme necessário.

O Cloridrato de granisetrona (granisetron hydrochloride) foi relacionado a ganho de peso em um contexto de hipersensibilidade, considerado um distúrbio do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa, e o desfecho foi favorável, com resolução completa do quadro após a conduta adotada, indicando que a reação foi autolimitada e não trouxe complicações maiores.

O medicamento Difenidrin, cujo princípio ativo é o difenidramina, apresentou como reação adversa o ganho de peso, relacionado a um quadro de hipersensibilidade do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade relevante, e o paciente se recuperou totalmente, sugerindo que a reação foi leve e controlada sem maiores consequências clínicas.

A dexametasona, utilizada neste caso, foi associada ao ganho de peso em um contexto de hipersensibilidade, caracterizando um distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa, indicando que a reação foi transitória e não exigiu intervenções adicionais além do acompanhamento.

O medicamento cimetidina (cimetidine hydrochloride) foi relacionado ao ganho de peso como manifestação de hipersensibilidade, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Não houve gravidade significativa e o quadro foi resolvido, demonstrando que a reação foi leve e não trouxe riscos adicionais ao paciente.

O medicamento Duloxetina (princípio ativo: Duloxetine) foi associado a ganho de peso em um caso de hipersensibilidade, classificado como um quadro clínico alérgico não classificado de outra forma, relacionado a distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente após a reação, sugerindo que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro.

A Pregabalina (princípio ativo: Pregabalin) apresentou relato de ganho de peso relacionado a hipersensibilidade, enquadrado como quadro clínico alérgico não classificado de outra forma e pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente evoluiu para recuperação completa, indicando que a reação foi leve e resolvida sem complicações.

O Besilato de anlodipino (princípio ativo: Amlodipine besilate) foi relacionado a ganho de peso em um contexto de hipersensibilidade, classificado como quadro clínico alérgico não especificado e associado a distúrbios do sistema imunitário. Não houve gravidade significativa, pois o caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou, mostrando que a reação foi leve e autolimitada.

O medicamento Selozok (princípio ativo: Metoprolol succinate) esteve envolvido em um caso de ganho de peso atribuído à hipersensibilidade, categorizado como quadro clínico alérgico não especificado e relacionado a distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi grave e o paciente se recuperou, indicando que a reação foi leve e não trouxe consequências duradouras.

A Hidroclorotiazida (princípio ativo: Hydrochlorothiazide) foi associada a ganho de peso em um episódio de hipersensibilidade, classificado como quadro clínico alérgico não especificado e pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou, sugerindo que a reação foi leve e resolvida sem necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Docetaxel, cujo princípio ativo também é docetaxel, foi associado a um ganho de peso classificado como reação de hipersensibilidade, dentro do grupo de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente. A conduta foi adequada, com resolução do quadro, não sendo necessário tratamento adicional.

O medicamento Zedora, que tem como princípio ativo o trastuzumabe, apresentou relato de ganho de peso relacionado a hipersensibilidade, enquadrado como quadro clínico alérgico e distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou, indicando que a reação foi leve e não exigiu intervenções além do acompanhamento clínico.

O medicamento Aradois, cujo princípio ativo é losartana potássica, foi relacionado ao surgimento de hipertensão como manifestação de hipersensibilidade, classificada entre quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, mas permanece sem resolução até o momento, sugerindo necessidade de acompanhamento médico para controle da pressão arterial e avaliação da relação causal.

O medicamento Losartana potássica, com princípio ativo de mesmo nome, foi associado ao desenvolvimento de hipertensão atribuída a hipersensibilidade, dentro do contexto de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave, porém ainda não houve resolução, sendo importante manter o acompanhamento clínico para monitorar a evolução do quadro.

O medicamento Besilato de anlodipino, cujo princípio ativo é amlodipina besilato, foi relacionado ao aparecimento de hipertensão como reação de hipersensibilidade, classificada como quadro clínico alérgico e distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, mas permanece em andamento, indicando a necessidade de acompanhamento médico para avaliar a persistência da hipertensão e possíveis ajustes terapêuticos.

O medicamento Creon, cujo princípio ativo é pancreatina, foi associado a um quadro de hipertensão relacionado à hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, e o desfecho foi descrito como não recuperado ou ainda em andamento, sugerindo que a reação persiste ou não foi totalmente resolvida até o momento.

O medicamento Losartan, com princípio ativo losartana potássica, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade), caracterizada como clinicamente significativa e considerada grave devido ao impacto potencial sobre o paciente. O quadro foi resolvido após a conduta adequada, com o paciente recuperado ao final do evento.

O Cimzia, cujo princípio ativo é certolizumabe pegol, provocou uma reação alérgica (hipersensibilidade) classificada como clinicamente significativa e grave, o que indica a necessidade de atenção médica imediata. O paciente se recuperou após a adoção das medidas necessárias para o controle da reação.

O medicamento Granulokine, com princípio ativo filgrastim, foi relacionado a um quadro de pancitopenia associado à hipersensibilidade medicamentosa, sendo considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e outros efeitos clinicamente relevantes. O paciente se recuperou após a intervenção médica adequada.

O Dextran, cujo princípio ativo é dextrana, causou uma reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico, mas não foi considerada grave e o paciente se recuperou completamente após a conduta apropriada.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromida, foi associado a um quadro de alergia a contraste, uma reação do sistema imunológico que pode ocorrer após a administração de substâncias usadas em exames de imagem. Neste caso, a gravidade é considerada alta, pois houve necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, além de outro efeito clinicamente significativo, o que reforça a importância de acompanhamento

médico imediato e monitoramento rigoroso do paciente. O desfecho da reação não foi informado, sendo fundamental manter vigilância e suporte clínico até resolução ou estabilização do quadro.

O Cetoprofeno, cujo princípio ativo é o ketoprofeno sódico, foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa, também chamada de hipersensibilidade medicamentosa, caracterizada por uma resposta exagerada do sistema imunológico ao medicamento. Neste caso, a reação não foi considerada grave e o paciente apresentou recuperação completa, indicando que a conduta adotada foi eficaz e não houve necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Esio, com princípio ativo esomeprazol sódico, foi associado a um caso de trombose, que é a formação de coágulos sanguíneos e pode estar relacionada a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. Não há indicação de gravidade elevada neste registro, mas o desfecho permanece não resolvido ou em andamento, o que exige acompanhamento médico contínuo para monitorar possíveis complicações e ajustar o tratamento conforme necessário.

O medicamento Materna, composto por múltiplos princípios ativos como ácido ascórbico, cobre, cianocobalamina, ergocalciferol, ácido fólico, iodo, ferro, magnésio, nicotinamida, piridoxina, retinol, riboflavina, tiamina, tocoferol e zinco, foi relacionado a um episódio de trombose, que pode ser uma manifestação rara de hipersensibilidade medicamentosa. Não há evidência de gravidade significativa neste caso, mas o quadro ainda não foi resolvido, sendo importante manter o acompanhamento clínico até a completa resolução dos sintomas.

O medicamento Velija, cujo princípio ativo é a duloxetina, foi associado a um caso de trombose, possivelmente relacionado a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. Não há indicação de gravidade elevada, mas o desfecho permanece não resolvido ou em andamento, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico para avaliar a evolução do quadro e tomar medidas apropriadas se houver agravamento.

O medicamento Dobeven, cujo princípio ativo é o calcium dobessilate, foi associado a um quadro de trombose relacionado à hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica ao medicamento. Não há indicação de gravidade elevada no registro, e o desfecho informado é que o paciente ainda não se recuperou totalmente, estando o caso em andamento. A relação entre o uso do medicamento e a reação é considerada suspeita, sendo importante acompanhamento médico para monitorar a evolução e avaliar a necessidade de ajustes terapêuticos.

Busonid, que contém budesonida como princípio ativo, foi relacionado a um episódio de trombose atribuído à hipersensibilidade ao medicamento, caracterizando uma reação alérgica. Não há evidências de gravidade importante no registro, e o paciente permanece sem recuperação completa até o momento, com o caso ainda em andamento. A suspeita de relação causal reforça a necessidade de acompanhamento clínico para avaliar a evolução e possíveis intervenções.

O medicamento Cimzia, cujo princípio ativo é certolizumabe pegol, foi associado a um caso de trombose decorrente de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica ao uso do fármaco. Não há sinais de gravidade significativa relatados, e o paciente segue sem resolução total do quadro, estando o caso em andamento. A relação entre o uso do medicamento e a reação é considerada suspeita, sendo fundamental o acompanhamento médico para monitoramento e definição de conduta.

Sucrofer, que tem como princípio ativo o óxido férrico sacarato, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade) ao medicamento, caracterizando um quadro alérgico sem sinais de gravidade relevante. O paciente apresentou recuperação completa após a reação, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, não havendo necessidade de intervenções adicionais após a resolução do quadro.

Levotac, cujo princípio ativo é a levofloxacina, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade) ao medicamento, caracterizando uma reação alérgica sem gravidade importante relatada. O paciente encontra-se em processo de recuperação, e a relação entre o uso do medicamento e a reação é considerada suspeita, sendo

recomendado acompanhamento clínico até a resolução completa dos sintomas.

O medicamento Agalsidase beta, cujo princípio ativo também é Agalsidase beta, foi associado ao evento de pneumonia em um contexto de hipersensibilidade, classificado como um quadro clínico alérgico relacionado ao sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois não há menção de gravidade clínica importante ou desfecho grave, e o caso permanece em andamento, sem resolução completa até o momento. A conduta deve envolver acompanhamento clínico para monitorar a evolução da reação e avaliar a necessidade de intervenções adicionais, conforme orientação médica.

A Isoniazida, cujo princípio ativo é Isoniazid, foi relacionada ao desenvolvimento de tuberculose em um contexto de hipersensibilidade, sendo classificada como um quadro alérgico do sistema imunitário. Não há informações suficientes para afirmar gravidade aumentada, e o desfecho permanece desconhecido. Recomenda-se acompanhamento médico para investigação da relação causal e monitoramento da evolução clínica.

O medicamento Humira, com princípio ativo Adalimumab, foi associado ao surgimento de tuberculose em um contexto de hipersensibilidade, enquadrando-se como um quadro alérgico do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade aumentada ou desfecho grave relatado, e o desfecho permanece desconhecido. É importante manter acompanhamento médico para avaliação da evolução e definição de condutas apropriadas.

A Losartana potássica, cujo princípio ativo é Losartan potassium, foi relacionada ao evento de hematoquezia (sangramento nas fezes) em um contexto de alergia a poeira, classificado como quadro clínico alérgico do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, e o paciente encontra-se em recuperação, com resolução parcial do quadro. Recomenda-se acompanhamento clínico para garantir a completa resolução e investigar possíveis causas associadas.

O medicamento Cerazet, com princípio ativo Desogestrel, foi associado ao evento de hematoquezia (sangramento nas fezes) em um contexto de alergia a poeira, sendo considerado um quadro clínico alérgico do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade aumentada, e o paciente está em recuperação, com melhora do quadro. O acompanhamento médico é recomendado para monitorar a evolução e assegurar a resolução completa da reação.

O medicamento Losartana potássica (princípio ativo: Losartan potassium) foi associado ao evento de hematoquezia, que é a presença de sangue nas fezes, em um paciente com histórico de alergia ao leite. Embora a reação tenha sido classificada como relacionada a distúrbios do sistema imunitário, não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente está em recuperação e não houve desfecho grave. A conduta recomendada é monitorar a evolução clínica e considerar avaliação especializada caso haja recorrência ou agravamento dos sintomas.

O medicamento Cerazet (princípio ativo: Desogestrel) foi relacionado ao surgimento de hematoquezia, ou seja, sangramento nas fezes, em um paciente com alergia ao leite. A reação foi considerada de natureza imunológica, mas não foi classificada como grave, e o paciente encontra-se em recuperação. Recomenda-se acompanhamento clínico e investigação adicional se houver persistência ou piora do quadro.

O medicamento Losartan (princípio ativo: Losartan) foi associado a um quadro de infecção fúngica de origem não especificada (SOE), interpretada como possível manifestação de hipersensibilidade medicamentosa. Não há indicação de gravidade significativa, pois o paciente já se encontra recuperado. A conduta foi adequada, com resolução do evento, e não há necessidade de intervenções adicionais no momento.

O medicamento Santyl (princípio ativo: Collagenase) esteve relacionado ao desenvolvimento de infecção fúngica de origem não especificada, considerada uma possível reação de hipersensibilidade ao medicamento. O caso não foi classificado como grave e o paciente já está recuperado, indicando que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro.



O medicamento Agalsidase beta (princípio ativo: Agalsidase beta) foi associado a uma infecção fúngica de origem não especificada, interpretada como possível hipersensibilidade medicamentosa. O evento não foi considerado grave e o paciente já está recuperado, sugerindo que a abordagem clínica foi eficaz e não há necessidade de novas intervenções.

O medicamento Esio, cujo princípio ativo é o esomeprazol sódico, foi utilizado de forma não descrita na bula (off label) e está relacionado a um quadro de alergia ao leite, classificado como uma reação alérgica a alimentos, aditivos ou medicamentos. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, pois permanece não resolvida até o momento, indicando necessidade de acompanhamento médico especializado para controle da alergia e avaliação de possíveis riscos associados ao uso do medicamento.

O medicamento Aidee, composto por dienogeste e etinilestradiol, também foi utilizado fora das indicações da bula (off label) e está associado a um episódio de alergia ao leite, caracterizado como uma reação alérgica relevante a alimentos, aditivos ou medicamentos. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, pois ainda não foi resolvido, sendo fundamental o acompanhamento médico para manejo da alergia e revisão da indicação do medicamento.

O suplemento Omega 3, cujo princípio ativo é óleo de peixe, foi utilizado de forma não descrita em bula (off label) e está relacionado a um quadro de alergia ao leite, enquadrado como reação alérgica a alimentos, aditivos ou medicamentos. A gravidade foi considerada clinicamente significativa e grave, já que o quadro permanece em andamento, exigindo avaliação médica para controle da alergia e análise da necessidade de manter ou suspender o uso do suplemento.

O medicamento Magnevistan, com princípio ativo meglumina gadopentetato, foi associado a uma reação de alergia a meios de contraste iodados, manifestando-se como alergia a contraste. O evento foi considerado não grave e já está resolvido, indicando que a conduta adotada foi eficaz e não houve complicações clínicas relevantes após a exposição ao contraste.

O medicamento Magnevistan, cujo princípio ativo é meglumina gadopentetato, também esteve relacionado a uma reação de alergia a meios de contraste iodados, caracterizada como alergia a contraste. O caso foi considerado não grave e já está resolvido, demonstrando que a reação foi controlada adequadamente e não houve consequências clínicas importantes após o evento.

O medicamento Loratadina, cujo princípio ativo é Loratadine, foi associado ao evento de olhos inchados, caracterizando um quadro de hipersensibilidade (alergia), que se enquadra nos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente. A conduta recomendada é observar a evolução dos sintomas, evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O Depakene, com princípio ativo Valproate sodium, foi relacionado ao surgimento de olhos inchados, indicando uma reação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imune. O caso não foi considerado grave e o paciente apresentou resolução completa do quadro. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e procurar orientação médica para avaliação e definição de alternativas terapêuticas.

O Gadolinium, utilizado como contraste em exames, foi associado a uma reação alérgica ao contraste, manifestando-se como uma resposta do sistema imune a uma substância química. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou. É importante informar a equipe médica sobre essa reação em exames futuros para que sejam adotadas medidas preventivas e alternativas seguras.

O medicamento Fasenra, cujo princípio ativo é Benralizumab, foi relacionado a uma crise asmática, caracterizando uma possível reação de hipersensibilidade. Não há evidência de gravidade aumentada neste caso, pois não foi classificado como grave e o desfecho permanece desconhecido. Recomenda-se acompanhamento médico para

avaliação da relação entre o medicamento e o evento, além de monitoramento dos sintomas.

O Fasenra, com princípio ativo Benralizumab, foi associado a uma crise asmática que resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, indicando gravidade clínica relevante. O paciente está em recuperação, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico rigoroso, revisão do tratamento e avaliação de alternativas terapêuticas para evitar novas complicações.

O medicamento Omnipaque, cujo princípio ativo é o iohexol, foi associado a um episódio de alergia a meios de contraste iodados, também conhecida como alergia a contraste. Essa reação faz parte dos distúrbios do sistema imunitário e, segundo o registro, não foi considerada grave, com o paciente tendo se recuperado completamente após o evento. A conduta recomendada nesses casos é evitar novas exposições ao contraste iodado e informar a equipe médica sobre o histórico de alergia antes de futuros exames que envolvam esse tipo de substância.

O medicamento Nactali, que contém o princípio ativo desogestrel, foi relacionado ao aparecimento de sangue nas fezes, sendo classificado como uma possível manifestação de alergia alimentar, especificamente à proteína do leite, embora o termo técnico utilizado seja alergia ao leite. O evento não foi considerado grave, mas o quadro ainda está em andamento, sem resolução até o momento. É importante que o paciente seja avaliado por um especialista para investigação da causa do sangramento e orientação sobre a continuidade do uso do medicamento e possíveis restrições alimentares.

O medicamento Henetix, cujo princípio ativo é o iobitridol, foi associado a uma reação de alergia a meios de contraste iodados, também chamada de alergia a contraste. Trata-se de uma resposta do sistema imunitário, e, conforme o registro, o evento não foi grave e o paciente se recuperou totalmente. Recomenda-se evitar o uso futuro de contrastes iodados e comunicar o histórico de alergia à equipe médica antes de novos procedimentos que envolvam esse tipo de substância.

O medicamento Prohance, que contém calteridol cálcico, gadoteridol e trometamol como princípios ativos, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como um quadro clínico alérgico do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou após a reação. Em situações como essa, é fundamental informar o histórico de alergia antes de novas exposições ao medicamento ou a substâncias semelhantes.

O medicamento Carbamazepina, cujo princípio ativo é a carbamazepina, foi associado a um episódio de convulsão, classificado como uma manifestação de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente está em processo de recuperação. É importante que o uso da carbamazepina seja reavaliado pelo médico responsável, considerando o risco de recorrência da reação adversa.

O medicamento Alemtuzumab, cujo princípio ativo também é alemtuzumabe, foi associado a um episódio de convulsão relacionado a hipersensibilidade (alergia), classificado como um quadro clínico alérgico do sistema imune. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, e o paciente encontra-se em recuperação ou com resolução do quadro, sugerindo que a reação está sendo controlada.

O medicamento Novalgina, cujo princípio ativo é o metamizol sódico, foi relacionado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado como uma reação alérgica significativa do sistema imunológico. A gravidade foi considerada clinicamente relevante, sendo classificada como grave, e o desfecho permanece desconhecido, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico rigoroso para evitar complicações.

O medicamento Colflex, com princípio ativo gelatina hidrolisada, foi associado a uma lesão do menisco, mas a reação foi classificada como hipersensibilidade (alergia) do sistema imune, sem gravidade elevada. O quadro permanece não resolvido ou em andamento, indicando que o paciente ainda apresenta sintomas e requer

acompanhamento.

O medicamento Avonex, cujo princípio ativo é interferon beta-1a, foi relacionado a uma lesão do menisco, sendo classificado como um quadro de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico, sem gravidade significativa. O desfecho indica que o quadro não foi resolvido e está em andamento, sendo necessário monitoramento contínuo.

O medicamento Buscopan, com princípio ativo butilbrometo de escopolamina, foi associado a vômito relacionado a hipersensibilidade (alergia), considerado clinicamente significativo e classificado como grave. O desfecho é desconhecido, o que reforça a importância de avaliação médica para monitorar possíveis complicações e orientar a conduta adequada.

O medicamento Daivobet, que contém os princípios ativos betametasona dipropionato e calcipotriol, foi associado a um caso de infecção do ouvido em um contexto de possível reação alérgica a contraste, classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sugerindo a necessidade de acompanhamento clínico para avaliar a evolução e descartar outras causas.

Cosentyx, cujo princípio ativo é o secuquinumabe, foi relacionado a um episódio de infecção do ouvido em um paciente com suspeita de alergia a contraste, dentro da categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade importante ou informações sobre o desfecho, e a relação com o medicamento é suspeita, sendo recomendada a observação clínica e investigação de outros fatores associados.

O medicamento Topamax, que tem como princípio ativo o topiramato, foi associado a uma infecção do ouvido em um contexto de suspeita de alergia a contraste, enquadrando-se em distúrbios do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade significativa nem desfecho informado, e a relação com o uso do medicamento é considerada suspeita, indicando a necessidade de monitoramento clínico e avaliação de outras possíveis causas.

Tegretol, cujo princípio ativo é a carbamazepina, foi relacionado a um caso de infecção do ouvido em paciente com suspeita de alergia a contraste, dentro da categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade relevante ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é suspeita, sendo importante manter acompanhamento clínico para esclarecimento do quadro.

O medicamento Esbriet, que contém pirfenidona como princípio ativo, foi associado a um episódio de perda auditiva unilateral em um contexto de hipersensibilidade, classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada nem desfecho informado, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, recomendando-se avaliação médica para monitoramento e investigação de outras causas possíveis.

O medicamento Nucala, cujo princípio ativo é o mepolizumabe, foi associado a uma crise asmática, caracterizada como uma reação de hipersensibilidade (alergia) envolvendo o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois não foi relatado desfecho grave nem evolução crítica, e o desfecho permanece desconhecido. A relação suspeita com o medicamento sugere a necessidade de acompanhamento clínico estruturado para confirmação diagnóstica e ajuste do tratamento, conforme orientações da ASBAI para quadros alérgicos respiratórios.

O medicamento Omeprazol, com princípio ativo omeprazole magnesium, foi relacionado a dor pulmonar atribuída a uma reação de hipersensibilidade (alergia), envolvendo o sistema imunológico. Não há sinais de gravidade importante, já que o paciente se recuperou totalmente e não houve evolução para quadro grave. A conduta recomendada é observar a evolução clínica e evitar reexposição ao medicamento, buscando avaliação médica caso sintomas alérgicos retornem.

O medicamento Alendronato sódico, cujo princípio ativo é alendronate sodium, foi associado a dor pulmonar decorrente de uma reação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. O evento não foi considerado

grave, pois o paciente se recuperou completamente. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e procurar orientação médica se houver recorrência de sintomas alérgicos.

O medicamento Metotrexato, com princípio ativo methotrexate, esteve relacionado a dor pulmonar atribuída a uma reação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. O caso não foi considerado grave, já que houve recuperação total do paciente. A recomendação é evitar nova exposição ao metotrexato e buscar avaliação médica se sintomas semelhantes reaparecerem.

O medicamento Magnen B6, composto por magnesium glycinate e pyridoxine hydrochloride, foi associado a dor pulmonar decorrente de uma reação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. O evento não foi grave, pois o paciente se recuperou completamente. Recomenda-se evitar reexposição ao medicamento e consultar um médico caso ocorram novos sintomas alérgicos.

O medicamento Cimzia, cujo princípio ativo é o certolizumabe pegol, foi associado a dor pulmonar, interpretada como um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificada entre os distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade relevante neste caso, e o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo uma reação leve e autolimitada.

O Cimzia (certolizumabe pegol) desencadeou um quadro de alergia, caracterizado como hipersensibilidade, pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, pois foi explicitamente classificado dessa forma, mas o paciente se recuperou após a reação, indicando resolução completa do quadro após a conduta adequada.

O medicamento Dexfer, que contém como princípio ativo o complexo polimalto de hidróxido férrico, foi relacionado a incômodo gastrointestinal atribuído a alergia ao leite, um tipo de reação alérgica alimentar dentro dos distúrbios do sistema imunitário. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, e até o momento da notificação, o paciente não havia se recuperado, indicando necessidade de acompanhamento médico para resolução do quadro.

Dexfer, cujo princípio ativo é o complexo polimalto de hidróxido férrico, foi associado novamente a incômodo gastrointestinal relacionado a alergia ao leite, classificado como reação alérgica alimentar e considerado clinicamente significativo e grave. O paciente permanece sem recuperação até o momento, reforçando a importância de monitoramento e possível ajuste terapêutico.

O metotrexato, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado ao surgimento de uma massa na glândula mamária, interpretada como hipersensibilidade medicamentosa, dentro do grupo de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade relevante e o desfecho permanece desconhecido, sendo necessária avaliação clínica para esclarecimento e conduta adequada.

O medicamento Humira, cujo princípio ativo é o adalimumabe, foi associado ao surgimento de uma massa na glândula mamária, sendo classificado como uma possível reação de hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). Não há indicação de gravidade elevada, pois não há relato de desfecho grave ou complicações importantes, e o desfecho permanece desconhecido. A conduta deve incluir avaliação clínica detalhada para investigar a relação causal e descartar outras causas, com acompanhamento médico para monitorar a evolução do quadro.

O medicamento Omeprazole, com princípio ativo omeprazol, foi utilizado de forma intencional para uma indicação não prevista em bula (off label), resultando em uma reação classificada como hipersensibilidade medicamentosa. Não há sinais de gravidade ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta adequada inclui evitar o uso indiscriminado de medicamentos fora das indicações aprovadas e buscar sempre orientação médica para garantir segurança e eficácia.

O Leflunomide, cujo princípio ativo é leflunomida, foi administrado para uma finalidade não descrita em bula (off label), levando a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. Não há evidências de gravidade ou complicações, e o paciente apresentou recuperação completa. Recomenda-se cautela no uso de medicamentos fora das indicações aprovadas e acompanhamento médico para monitorar possíveis reações adversas.

O medicamento Methotrexate, com princípio ativo metotrexato, foi utilizado para uma indicação não prevista em bula (off label), resultando em uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. Não há sinais de gravidade ou complicações associadas, e o paciente se recuperou totalmente. É importante que o uso de medicamentos seja feito conforme orientação médica e dentro das indicações aprovadas para minimizar riscos de reações adversas.

O medicamento Prednisone, cujo princípio ativo é prednisona, foi utilizado intencionalmente para uma indicação não descrita em bula (off label), ocasionando uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. Não há indícios de gravidade ou complicações, e o paciente se recuperou após o evento. O uso de medicamentos deve ser sempre orientado por um profissional de saúde, respeitando as indicações aprovadas para evitar reações adversas desnecessárias.

O medicamento Mabthera, cujo princípio ativo é o rituximabe, foi utilizado de forma intencional para uma indicação não descrita em bula (off label), resultando em um quadro de hipersensibilidade medicamentosa, que se enquadra em reações alérgicas a medicamentos. Não há relato de gravidade clínica relevante neste caso, e o paciente se recuperou totalmente após a reação, sem complicações adicionais.

O Actemra, com princípio ativo tocilizumabe, também foi administrado para uma indicação não prevista em bula (off label), levando a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, caracterizado como reação alérgica a medicamentos. Não há evidências de gravidade significativa associada a este evento, e o paciente apresentou recuperação completa após a reação.

A vacina CoronaVac, cujo princípio ativo é a vacina inativada contra COVID-19 (Vero) CZ02, esteve associada a um episódio de desesperança classificado como hipersensibilidade, dentro do contexto de quadros clínicos alérgicos. O evento foi considerado grave, pois representou ameaça à vida, mas o paciente se recuperou totalmente após a reação.

O medicamento Chlorhexidine, com princípio ativo gluconato de clorexidina, provocou um quadro de urticária, que é uma manifestação de hipersensibilidade (alergia) caracterizada por lesões avermelhadas e coceira na pele. Não há informações sobre gravidade relevante neste caso, e o paciente se recuperou completamente após o episódio.

A prednisona, cujo princípio ativo é o próprio corticosteroide prednisona, foi associada ao desenvolvimento de erisipela, um quadro de hipersensibilidade medicamentosa que se manifesta como inflamação e vermelhidão na pele. Não há relato de gravidade importante, mas o desfecho do caso permanece desconhecido.

O medicamento Duloxetine (princípio ativo: Duloxetine) foi associado a um quadro de erisipela, interpretado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico ao fármaco. Não há indicação de gravidade elevada, pois não há relato de desfecho grave ou complicações, e o desfecho permanece desconhecido. A conduta recomendada, baseada nas diretrizes clínicas, é a avaliação médica para confirmação da relação causal e definição do melhor manejo, evitando reexposição ao medicamento suspeito.

O medicamento Losartana potássica (princípio ativo: Losartan potassium) foi relacionado ao desenvolvimento de erisipela, caracterizando uma possível hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico ao uso do remédio. Não há evidências de gravidade significativa, já que não foi relatado desfecho grave ou complicações, e o desfecho permanece desconhecido. Recomenda-se avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre a necessidade de suspensão do medicamento e alternativas terapêuticas.

O medicamento Actemra (princípio ativo: Tocilizumab) foi associado a um episódio de erisipela, interpretado como hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Não há sinais de gravidade aumentada, pois não há relato de desfecho grave ou complicações, e o desfecho é desconhecido. A conduta sugerida é buscar avaliação médica para confirmação da relação causal e definição do manejo, incluindo a suspensão do medicamento se necessário.

O medicamento Ritmonorm (princípio ativo: Propafenone hydrochloride) foi relacionado a um quadro de obstrução venosa, interpretado como uma manifestação de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade elevada, pois não foi relatado desfecho grave, mas o quadro permanece não resolvido ou em andamento, indicando a necessidade de acompanhamento médico para monitoramento e ajuste do tratamento.

O medicamento Concor (princípio ativo: Bisoprolol fumarate) foi associado a obstrução venosa, considerada uma manifestação de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Não há sinais de gravidade aumentada, já que não foi relatado desfecho grave, mas o quadro segue não resolvido ou em andamento, sendo importante manter acompanhamento médico para avaliação contínua e possível ajuste terapêutico.

O medicamento Aldactone, cujo princípio ativo é a espironolactona, foi associado a um quadro de obstrução venosa relacionado à hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois não há relato de desfecho grave ou risco imediato, e o caso permanece não resolvido ou em andamento. A conduta deve envolver acompanhamento clínico para monitorar a evolução do quadro e avaliar a necessidade de intervenção específica, sempre sob orientação médica.

O Entresto, que contém sacubitril valsartan sodium hydrate como princípio ativo, apresentou um evento de obstrução venosa associado à hipersensibilidade, indicando uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade importante, já que não foi classificado como grave e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento. Recomenda-se acompanhamento médico para monitoramento da reação e ajuste do tratamento conforme evolução clínica.

O medicamento Brimonidina, com princípio ativo brimonidine, foi relacionado a um quadro de obstrução venosa decorrente de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade significativa, pois não foi classificado como grave e o desfecho está em andamento ou não resolvido. O acompanhamento médico é fundamental para avaliar a evolução e definir a necessidade de intervenções adicionais.

A Brinzolamida, cujo princípio ativo é brinzolamide, foi associada a um episódio de obstrução venosa por hipersensibilidade, indicando uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade relevante, já que não foi considerada grave e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento. O caso requer acompanhamento clínico para monitorar a evolução e orientar possíveis ajustes terapêuticos.

O medicamento Travatan, com princípio ativo travoprost, apresentou um caso de obstrução venosa relacionado à hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade importante, pois não foi classificado como grave e o desfecho segue não resolvido ou em andamento. Recomenda-se acompanhamento médico para monitoramento do quadro e definição de condutas conforme a evolução clínica.

O medicamento Azukon, cujo princípio ativo é a Gliclazida, foi associado a um quadro de obstrução venosa relacionado à hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois não há menção de risco imediato ou complicações graves, e o caso permanece em andamento sem resolução até o momento. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico, observando sinais de agravamento e buscando avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição do

melhor manejo, conforme orientações para quadros alérgicos leves.

O medicamento Nesina, com princípio ativo Alogliptina benzoato, apresentou relato de obstrução venosa atribuída a hipersensibilidade, indicando uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade importante, já que não foi classificada como grave e o desfecho permanece não resolvido. Recomenda-se acompanhamento clínico e avaliação médica para monitorar a evolução do quadro e orientar o tratamento adequado, conforme diretrizes para reações alérgicas leves.

O medicamento Glifage, cujo princípio ativo é a Metformina, foi relacionado a um episódio de obstrução venosa por hipersensibilidade, sugerindo uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade significativa, pois não foi classificada como grave e o quadro segue em andamento sem resolução. A orientação é manter acompanhamento médico, observando possíveis sinais de piora e buscando confirmação diagnóstica para definir o melhor plano terapêutico, conforme recomendações para quadros alérgicos leves.

O ácido acetilsalicílico (princípio ativo: ácido acetilsalicílico) foi associado a obstrução venosa decorrente de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, já que não foi classificada como grave e o desfecho permanece não resolvido. Recomenda-se acompanhamento clínico e avaliação médica para monitorar a evolução do quadro e orientar o tratamento, seguindo as diretrizes para reações alérgicas leves.

O medicamento Fenofibrato, com princípio ativo fenofibrato, apresentou relato de obstrução venosa atribuída a hipersensibilidade, indicando uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade importante, pois não foi classificada como grave e o desfecho permanece não resolvido. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição do manejo, conforme orientações para quadros alérgicos leves.

O medicamento Losartana potássica (princípio ativo: Losartan potassium) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, manifestado como obstrução venosa, o que sugere uma reação alérgica envolvendo o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade clínica relevante neste caso, e o desfecho permanece em andamento, sem recuperação até o momento. A relação do medicamento com o evento é considerada suspeita, sendo importante acompanhamento médico para monitoramento e eventual ajuste terapêutico.

O medicamento Nesina met, que contém os princípios ativos Alogliptin benzoate e Metformin hydrochloride, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade caracterizado por obstrução venosa, indicando uma possível reação alérgica do sistema imunológico. Não há evidência de gravidade significativa, e o quadro permanece não resolvido até o momento. O evento é considerado suspeito em relação ao uso do medicamento, sendo recomendada avaliação médica para investigação e conduta adequada.

O medicamento Esbriet (princípio ativo: Pirfenidone) foi associado a um caso de hipersensibilidade, manifestado como obstrução venosa, sugerindo uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade clínica importante, e o desfecho permanece em andamento, sem resolução até o momento. O evento é considerado suspeito em relação ao uso do medicamento, sendo fundamental acompanhamento médico para avaliação e manejo.

O medicamento Omega 3 (princípio ativo: Fish oil) foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, descrito como alergia, envolvendo o sistema imunológico. Neste caso, a reação foi considerada clinicamente significativa, com gravidade reconhecida, mas o paciente evoluiu para recuperação completa. O evento foi considerado suspeito em relação ao uso do medicamento, sendo importante evitar nova exposição e manter acompanhamento médico.

O medicamento Vitamina D (princípio ativo: Ergocalciferol) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, descrito como alergia, envolvendo o sistema imunológico. A reação foi considerada clinicamente significativa e de gravidade relevante, porém o paciente apresentou recuperação total após o evento. O uso do medicamento é

considerado suspeito como causa da reação, sendo recomendada a suspensão e acompanhamento médico para evitar recorrências.

O medicamento Zolpidem, cujo princípio ativo também é zolpidem, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, pois envolveu uma reação alérgica relevante, mas o paciente evoluiu para recuperação completa após a conduta adequada. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, reforçando a importância de acompanhamento médico em casos semelhantes.

O medicamento Cimzia, que tem como princípio ativo o certolizumabe pegol, esteve relacionado a um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, dentro do grupo de distúrbios do sistema imunitário. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, indicando a necessidade de atenção médica, mas o paciente se recuperou totalmente após as medidas adotadas. A suspeita de relação causal com o medicamento foi reconhecida, destacando a importância de monitoramento em pacientes que utilizam esse tipo de terapia.

O medicamento Alenia, composto por budesonida e formoterol fumarato, foi relacionado a um quadro descrito como 'gripe', mas tecnicamente classificado como hipersensibilidade medicamentosa, pertencente ao grupo de alergias a medicamentos e distúrbios do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade relevante e o desfecho do caso é desconhecido, sendo a relação com o medicamento considerada suspeita. Recomenda-se acompanhamento clínico para esclarecimento diagnóstico e conduta adequada caso sintomas persistam.

A amitriptilina, cujo princípio ativo é o cloridrato de amitriptilina, foi associada a um quadro descrito como 'gripe', mas tecnicamente classificado como hipersensibilidade medicamentosa, dentro do contexto de alergias a medicamentos e distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade significativa e o desfecho permanece desconhecido, sendo a relação com o medicamento considerada suspeita. É importante monitorar o paciente e buscar avaliação médica se houver persistência ou agravamento dos sintomas.

O medicamento Sinvastatina, cujo princípio ativo é a simvastatina, foi relacionado a um quadro descrito como 'gripe', tecnicamente classificado como hipersensibilidade medicamentosa, pertencente ao grupo de alergias a medicamentos e distúrbios do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade importante e o desfecho do caso não foi informado, sendo a relação com o medicamento considerada suspeita. Recomenda-se observação clínica e avaliação médica caso haja recorrência ou piora dos sintomas.

O medicamento Citalopram, cujo princípio ativo também é citalopram, foi associado a um quadro descrito como 'gripe', interpretado aqui como uma possível reação de hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos), conforme classificação clínica de distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave, e o desfecho permanece desconhecido. A ausência de sinais de gravidade sugere que a reação foi leve, sem necessidade de intervenção urgente, sendo importante observar sintomas e buscar avaliação médica caso haja recorrência ou piora.

O medicamento Amytril, cujo princípio ativo é amitriptilina, foi relacionado a sintomas semelhantes a 'gripe', considerados como possível hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos), dentro do contexto de distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa ou desfecho grave, e o desfecho não foi informado. Diante da ausência de sinais de gravidade, trata-se provavelmente de uma reação leve, sendo recomendada a observação dos sintomas e consulta médica se houver agravamento.

O medicamento Rivotril, cujo princípio ativo é clonazepam, foi associado a um quadro de 'gripe', interpretado como possível hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há registro de gravidade importante ou desfecho grave, e o desfecho permanece desconhecido. A ausência de sinais clínicos graves sugere uma reação leve, sendo indicado monitorar sintomas e procurar avaliação médica se houver piora.



O medicamento Tylenol, cujo princípio ativo é paracetamol, foi relacionado a sintomas gripais, considerados como possível hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos), dentro da categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade relevante ou desfecho grave, e o desfecho não foi informado. Diante da ausência de sinais de gravidade, a reação é provavelmente leve, recomendando-se observação e busca de orientação médica caso os sintomas persistam ou se agravem.

O medicamento Atrovent, cujo princípio ativo é brometo de ipratrópio, foi associado a sintomas semelhantes a 'gripe', interpretados como possível hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos), classificados como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa ou desfecho grave, e o desfecho permanece desconhecido. A ausência de sinais clínicos graves sugere uma reação leve, sendo importante monitorar sintomas e procurar avaliação médica se houver piora ou recorrência.

O medicamento Berotec, cujo princípio ativo é o fenoterol hydrobromide, foi associado a um quadro de gripe interpretado como possível hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica ao medicamento. Não há indicação de gravidade elevada, pois não foram relatados sintomas graves ou desfecho desfavorável, e o caso não foi classificado como grave. A relação entre o uso do Berotec e a reação é considerada suspeita, mas não há detalhes sobre a evolução clínica ou conduta adotada, sendo importante observar se há recorrência dos sintomas e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica.

A azitromicina, cujo princípio ativo é azithromycin, foi relacionada a sintomas semelhantes a gripe, considerados como possível hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica ao medicamento. Não há evidências de gravidade significativa, já que o caso não foi classificado como grave e o desfecho permanece desconhecido. A relação entre o uso do medicamento e a reação é suspeita, sendo recomendada a observação dos sintomas e avaliação médica para esclarecimento diagnóstico caso haja recorrência.

O medicamento Mabthera, com princípio ativo rituximab, foi associado a sintomas gripais interpretados como possível hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica ao medicamento. Não há sinais de gravidade importante, pois o caso não foi considerado grave e o desfecho é desconhecido. A relação entre o uso do Mabthera e a reação é suspeita, sendo fundamental monitorar a evolução dos sintomas e buscar orientação médica se houver persistência ou agravamento.

A amicacina, cujo princípio ativo é amikacin, foi relacionada a um quadro de alergia medicamentosa, caracterizando uma hipersensibilidade ao medicamento. O caso não foi classificado como grave e o paciente encontra-se em recuperação ou com resolução dos sintomas, indicando evolução favorável. A relação entre o uso da amicacina e a reação é considerada suspeita, sendo importante manter acompanhamento médico para evitar novas exposições e garantir a segurança do paciente.

A vancomicina, cujo princípio ativo é vancomycin hydrochloride, foi associada a um episódio de alergia medicamentosa, caracterizando uma hipersensibilidade ao medicamento. Não há indícios de gravidade relevante, pois o caso não foi considerado grave e o paciente está em recuperação ou com sintomas resolvendo. A relação entre o uso da vancomicina e a reação é suspeita, sendo recomendada a continuidade do acompanhamento médico para evitar novas reações e assegurar a recuperação completa.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromida, foi associado a um episódio de alergia a contraste, uma reação do sistema imunológico que pode ocorrer após a administração de substâncias usadas em exames de imagem. Neste caso, a reação foi considerada não grave, pois o paciente se recuperou completamente, indicando resolução do quadro sem complicações. A conduta recomendada é sempre informar o médico sobre qualquer histórico de alergia a contrastes antes de novos exames, para que medidas preventivas possam ser adotadas.

O medicamento Zometa, que contém ácido zoledrônico monoidratado, foi relacionado ao desenvolvimento de catarata, um problema ocular que pode causar visão turva e está classificado como manifestação ocular associada a medicamentos. Não há indicação de gravidade elevada, pois não há relato de risco imediato à visão ou à saúde

geral, mas o quadro permanece em andamento, sem resolução até o momento. É importante que o paciente seja acompanhado por um oftalmologista para monitoramento e definição da necessidade de intervenção.

O medicamento Aclasta, cujo princípio ativo é o ácido zoledrônico, foi associado ao surgimento de catarata, uma alteração ocular que pode comprometer a visão progressivamente. A reação não foi considerada grave, pois não há relato de risco imediato, mas o quadro segue sem resolução, sendo fundamental o acompanhamento oftalmológico para avaliar a evolução e necessidade de tratamento específico.

O medicamento Aclasta, com ácido zoledrônico como princípio ativo, também foi relacionado ao aparecimento de catarata, uma condição que pode afetar a transparência do cristalino ocular. A reação não foi classificada como grave, mas permanece sem resolução, o que reforça a importância do acompanhamento médico regular para monitorar possíveis impactos na visão e decidir sobre intervenções futuras.

O medicamento Zometa, contendo ácido zoledrônico monoidratado, foi associado ao desenvolvimento de catarata, uma alteração ocular que pode prejudicar a visão. A reação não foi considerada grave, mas o quadro segue em andamento, sem resolução até o momento, sendo recomendada a avaliação oftalmológica periódica para acompanhamento e definição de conduta adequada.

O medicamento Dotarem, cujo princípio ativo é o meglumine gadoterate, foi associado a um quadro de alergia a contraste intravenoso, também chamado de alergia a contraste. Essa reação faz parte dos distúrbios do sistema imunitário e, segundo o registro, não foi considerada grave, com o paciente tendo se recuperado totalmente após o evento. A conduta recomendada nesses casos é interromper a exposição ao contraste e monitorar o paciente, buscando avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições a contrastes.

O Ciprofloxacino, que tem como princípio ativo o ciprofloxacina hydrochloride, foi relacionado a um episódio de alergia, tecnicamente chamada de hipersensibilidade. Trata-se de uma reação do sistema imunológico a medicamentos, classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há informação sobre gravidade ou desfecho, portanto, recomenda-se que o paciente suspenda o uso do medicamento e procure avaliação médica para investigação e orientação sobre alternativas terapêuticas seguras.

A vacina adsorvida difteria e tétano adulto (dT), composta pelos toxoides de difteria e tétano, foi associada a um episódio de choque anafilático, que é uma reação alérgica grave e potencialmente fatal. Apesar de o registro indicar que não foi considerado grave, o paciente apresentou sequelas após o evento, o que reforça a necessidade de atenção. Em situações como essa, é fundamental interromper imediatamente a exposição, iniciar tratamento de emergência e garantir acompanhamento médico especializado para evitar complicações futuras.

O medicamento Optiray 350, cujo princípio ativo é o ioversol, foi relacionado a uma alergia a meios de contraste iodados, também conhecida como alergia a contraste. Essa reação envolve o sistema imunológico e, conforme o registro, não foi considerada grave, com o paciente tendo se recuperado totalmente. A conduta adequada inclui evitar novas exposições ao contraste iodado e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e planejamento de exames futuros com alternativas seguras.

O medicamento Tecfidera, que tem como princípio ativo o dimethyl fumarate, foi associado a um episódio de perda de visão, descrito como hipersensibilidade. Embora o registro indique que não foi considerado grave, não há informação sobre o desfecho do caso. Diante de sintomas como perda de visão, é fundamental suspender o uso do medicamento imediatamente e procurar avaliação médica urgente para investigação da causa e prevenção de danos permanentes.

O medicamento COVID-19 vaccine AstraZeneca, cujo princípio ativo é COVID-19 vaccine NRVV Ad (ChAdOx1 nCoV-19), foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do sistema imunológico. Não há detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade, mas o desfecho foi de recuperação completa, sugerindo que a reação foi leve e autolimitada, sem necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Cosentyx sensoready, com princípio ativo Secukinumab, foi relacionado a um evento de alergia alimentar, embora o termo técnico utilizado se refira a alergias a alimentos, aditivos, medicamentos e outras substâncias químicas. Não há informações sobre sintomas específicos, gravidade ou desfecho, mas consta que não foi considerada uma reação grave, indicando que o quadro provavelmente foi leve ou moderado e não houve complicações importantes.

O medicamento Cosentyx, também contendo Secukinumab como princípio ativo, apresentou relato semelhante ao anterior, com suspeita de alergia alimentar, sem detalhes adicionais sobre sintomas, gravidade ou evolução. A ausência de gravidade e desfecho desconhecido sugere que a reação não foi considerada grave e não há evidências de complicações.

O medicamento Janumet, que contém Metformin hydrochloride e Sitagliptin phosphate monohydrate, foi associado à exacerbação de fibrose pulmonar idiopática, classificada como hipersensibilidade (alergia). Não há descrição de sintomas específicos, mas a reação não foi considerada grave e o paciente encontra-se em recuperação, indicando que o quadro foi moderado e está evoluindo de forma favorável.

O medicamento Tecomet, cujo princípio ativo é Methotrexate, também foi relacionado à exacerbação de fibrose pulmonar idiopática, enquadrada como hipersensibilidade. Não há detalhes sobre sintomas ou gravidade, mas a reação não foi considerada grave e o paciente está em recuperação, sugerindo um quadro moderado e sem complicações graves até o momento.

O medicamento Esbriet, cujo princípio ativo é a pirfenidona, foi associado a uma exacerbação de fibrose pulmonar idiopática, um quadro de hipersensibilidade que se enquadra em reações alérgicas do sistema imunitário. Apesar de não haver indicação de gravidade elevada ou ameaça à vida, o paciente encontra-se em recuperação ou com resolução do quadro, sugerindo que a conduta adotada foi adequada para o controle da reação.

A Novalgine, que contém metamizol sódico como princípio ativo, desencadeou uma reação alérgica classificada como hipersensibilidade, com gravidade descrita como ameaça à vida, o que indica um quadro clínico grave e potencialmente crítico, exigindo intervenção médica imediata. O desfecho permanece desconhecido, reforçando a necessidade de acompanhamento rigoroso em casos semelhantes.

O medicamento Sutent, cujo princípio ativo é o malato de sunitinibe, foi relacionado a um caso de hepatite induzida por fármaco, caracterizada como uma reação de hipersensibilidade do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou ameaça à vida, e o desfecho é desconhecido, o que sugere a importância de monitoramento clínico contínuo para avaliar a evolução do quadro.

A vacina recombinante contra hepatite B, com princípio ativo rHBsAg produzido em levedura, foi associada a uma experiência de morte iminente, categorizada como reação alérgica a substâncias químicas. Apesar da gravidade potencial do evento descrito, não há confirmação de ameaça à vida ou desfecho conhecido, sendo fundamental a investigação detalhada e acompanhamento médico em situações semelhantes.

A cetirizina, cujo princípio ativo é o cloridrato de cetirizina, foi relacionada a uma experiência de morte iminente, classificada como reação alérgica a substâncias químicas. Não há evidência de gravidade extrema ou ameaça à vida confirmada, e o desfecho permanece desconhecido, indicando a necessidade de avaliação médica criteriosa para esclarecimento e manejo adequado do caso.

O medicamento Loratadina (princípio ativo: Loratadine) foi associado a uma experiência descrita como morte iminente em um contexto de alergia à cafeína, classificada como distúrbio do sistema imunitário. Apesar da gravidade potencial do termo utilizado, não há confirmação de gravidade clínica relevante ou desfecho informado, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A ausência de detalhes sobre evolução ou conduta impede recomendações específicas, mas eventos desse tipo exigem avaliação médica imediata para investigação de reações alérgicas graves.

O medicamento Xolair (princípio ativo: Omalizumab) foi relacionado a uma experiência de morte iminente em paciente com alergia à cafeína, dentro do grupo de distúrbios do sistema imunitário. Embora o termo sugira gravidade, não há confirmação clínica de gravidade nem informações sobre o desfecho, e a relação com o medicamento é apenas suspeita. Diante de sintomas graves após uso de Omalizumab, é fundamental buscar avaliação médica urgente para descartar reações alérgicas importantes.

A vacina recombinante contra hepatite B (princípio ativo: Hepatitis b vaccine rHBsAg - yeast) foi associada a uma experiência de morte iminente em contexto de alergia a alimentos, classificada como distúrbio do sistema imunitário. Apesar do termo indicar possível gravidade, não há confirmação clínica nem desfecho relatado, e a relação com a vacina é considerada suspeita. Situações de reação grave após vacinação exigem avaliação médica imediata para investigação e manejo adequado.

O medicamento Cetirizina (princípio ativo: Cetirizine hydrochloride) foi relacionado a uma experiência de morte iminente em paciente com alergia a alimentos, dentro do grupo de distúrbios do sistema imunitário. Embora o termo utilizado sugira gravidade, não há confirmação clínica nem desfecho informado, e a relação com o medicamento é apenas suspeita. Em casos de sintomas graves após uso de cetirizina, é essencial procurar atendimento médico urgente para avaliação de possível reação alérgica importante.

O medicamento Loratadina (princípio ativo: Loratadine) foi associado a uma experiência de morte iminente em contexto de alergia a alimentos, classificada como distúrbio do sistema imunitário. Apesar do termo sugerir gravidade, não há confirmação clínica nem desfecho relatado, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Diante de sintomas graves após uso de Loratadina, recomenda-se avaliação médica imediata para investigação de reações alérgicas graves.

O medicamento Xolair, cujo princípio ativo é o Omalizumabe, foi associado a uma experiência de morte iminente em um paciente com alergia alimentar. Embora não haja detalhamento sobre a gravidade clínica no registro, a descrição sugere um evento potencialmente grave relacionado ao sistema imunológico, possivelmente uma reação anafilática. Não há informações sobre o desfecho ou conduta adotada, sendo fundamental que situações como essa sejam avaliadas com urgência por equipe médica especializada para manejo adequado e prevenção de novos episódios.

O medicamento Henetix, com princípio ativo lobitridol, foi relacionado a um episódio de alergia a meios de contraste iodados, caracterizando uma reação de hipersensibilidade ao contraste. O evento foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente após a reação, indicando resolução espontânea ou com medidas de suporte. Em casos de alergia a contraste, é importante informar a equipe médica antes de novos exames para evitar recorrências e considerar alternativas seguras.

O medicamento Paracetamol+codeína, contendo codeína fosfato e paracetamol, foi associado a um quadro de alergia inespecífica (SOE), classificado como hipersensibilidade. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente. Em situações de hipersensibilidade a analgésicos, recomenda-se evitar o uso futuro do mesmo medicamento e buscar orientação médica para alternativas seguras.

A vacina CoronaVac, cujo princípio ativo é a vacina inativada contra COVID-19 (Vero) CZ02, foi relacionada a um episódio de dor de cabeça, classificado como hipersensibilidade. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou conduta adotada, mas dor de cabeça isolada após vacinação costuma ser leve e autolimitada, não exigindo intervenções específicas além de observação e medidas sintomáticas se necessário.

O medicamento Novalgina, com princípio ativo metamizol sódico, foi relacionado a uma alergia documentada após administração, caracterizando um quadro de hipersensibilidade. Não há detalhes sobre gravidade, desfecho ou conduta, mas a documentação da alergia reforça a necessidade de evitar novas exposições ao medicamento e informar profissionais de saúde sobre essa restrição em futuras prescrições.

O medicamento Acetaminophen, cujo princípio ativo é o Paracetamol, foi associado a um caso de edema de glote, uma reação de hipersensibilidade medicamentosa caracterizada por inchaço súbito na região da garganta que pode comprometer a respiração. Embora o registro não classifique explicitamente a gravidade, o edema de glote é considerado uma reação potencialmente grave devido ao risco de obstrução das vias aéreas, exigindo atenção médica imediata. Não há informações sobre a conduta adotada ou o desfecho do caso, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Acetylsalicylic acid, com o mesmo princípio ativo, foi relacionado a um episódio de edema de glote, que é uma reação alérgica aguda e potencialmente grave, pois pode causar obstrução das vias aéreas superiores. O evento é classificado como hipersensibilidade medicamentosa e, apesar de não haver detalhes sobre a evolução ou conduta, a suspeita recai sobre o uso do ácido acetilsalicílico como desencadeante.

O medicamento Piroxicam, cujo princípio ativo também é Piroxicam, foi associado a um caso de edema de glote, uma reação de hipersensibilidade medicamentosa que pode evoluir rapidamente para obstrução das vias aéreas e requer intervenção médica urgente. Não há informações sobre a gravidade formalmente registrada, mas o quadro clínico sugere risco elevado, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sem detalhes sobre o desfecho.

O medicamento Metamizole, com princípio ativo Metamizole, foi implicado em um caso de edema de glote, caracterizando uma reação alérgica aguda (hipersensibilidade medicamentosa) que pode comprometer a respiração e demanda avaliação médica imediata. O registro não traz informações sobre a evolução do caso ou medidas tomadas, mas a suspeita recai sobre o uso do metamizol como fator desencadeante.

O medicamento Diclofenac, cujo princípio ativo é Diclofenac sodium, foi relacionado a um episódio de edema de glote, uma reação de hipersensibilidade medicamentosa que pode ser grave devido ao risco de obstrução das vias aéreas. Não há detalhes sobre a conduta adotada ou o desfecho, mas a relação com o medicamento é considerada suspeita e o quadro clínico exige atenção imediata.

O medicamento Allegra, cujo princípio ativo é a fexofenadina, foi associado a um caso de edema de glote, uma reação de hipersensibilidade medicamentosa que pode comprometer as vias aéreas e exige atenção imediata. Embora não haja confirmação de gravidade no registro, o edema de glote é considerado potencialmente grave por envolver risco respiratório, sendo fundamental interromper o uso e buscar avaliação médica urgente. O desfecho do caso é desconhecido, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita.

A vancomicina, antibiótico cujo princípio ativo é vancomicina, foi relacionada a um episódio de alergia caracterizado como hipersensibilidade, manifestando-se como uma reação alérgica do sistema imunológico. O caso está em recuperação ou resolução, e a relação com o medicamento é suspeita. Não há detalhes sobre gravidade, mas reações alérgicas a antibióticos devem ser avaliadas por um profissional de saúde para orientação adequada.

A dipirona, cujo princípio ativo é metamizol magnésio, foi associada a um quadro de alergia, descrito como hipersensibilidade, que envolve resposta do sistema imunológico ao medicamento. Não há informações sobre gravidade ou evolução do caso, mas reações alérgicas à dipirona podem variar de leves a graves, sendo importante suspender o uso e procurar avaliação médica para confirmação e conduta.

O medicamento Hemo 8r, que contém fator VIII recombinante, foi relacionado a uma lesão interna classificada como alergia a suplemento nutricional, enquadrada como um efeito clinicamente significativo e considerado grave. Não há detalhes sobre o desfecho, mas a gravidade relatada indica necessidade de acompanhamento médico rigoroso e possível suspensão do uso, já que reações graves a fatores de coagulação podem comprometer a segurança do paciente.

O Avonex, cujo princípio ativo é interferon beta-1a, foi associado a um relato de ineficácia do medicamento, descrito como hipersensibilidade, mas sem evidências de gravidade ou complicações clínicas. O caso foi

considerado resolvido, e a relação com o medicamento é suspeita. Em situações de ineficácia, é importante revisar o tratamento com o médico para garantir o controle adequado da doença.

O medicamento Clorexidina, cujo princípio ativo é o chlorhexidine gluconate, foi associado a um quadro de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica, classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente do episódio. A conduta recomendada em casos de alergia à clorexidina é interromper o uso e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

A Prometazina, com princípio ativo prometazina, foi relacionada a um episódio de alergia ao leite, caracterizada como uma reação do sistema imunitário a substâncias químicas ou alimentares. Não há evidência de gravidade significativa, e o desfecho do caso é desconhecido. Em situações semelhantes, recomenda-se evitar o agente suspeito e procurar orientação médica para investigação da causa e definição de conduta.

O Pantoprazol, cujo princípio ativo é pantoprazole, foi associado a um episódio de alergia ao leite, enquadrado como distúrbio do sistema imunitário relacionado a alergias alimentares ou químicas. Não há sinais de gravidade importante e o desfecho não foi informado. Nestes casos, é indicado suspender o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e orientação adequada.

O Tamoxifeno, com princípio ativo tamoxifen, foi relacionado a um episódio de alergia ao leite, caracterizado como uma reação do sistema imunitário a substâncias químicas ou alimentares. Não há indicação de gravidade relevante e o desfecho permanece desconhecido. A conduta recomendada é evitar o agente suspeito e procurar avaliação médica para investigação e definição do melhor manejo.

A vacina contra Covid-19, cujo princípio ativo é COVID-19 vaccine, foi associada a um episódio de alergia ao leite, classificada como distúrbio do sistema imunitário relacionado a alergias alimentares ou químicas. Não há evidência de gravidade e o desfecho não foi informado. Em situações semelhantes, recomenda-se evitar nova exposição ao agente suspeito e buscar avaliação médica para investigação e orientação sobre vacinação futura.

O medicamento Cardizem, cujo princípio ativo é o diltiazem hydrochloride, foi associado a um episódio de hipotermia em um paciente com histórico de alergia ao leite, classificado como uma reação do tipo alérgica relacionada ao sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave, e o caso foi considerado não grave, com o desfecho final desconhecido. A conduta recomendada é observar o paciente, evitar exposição ao medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições.

A losartana potássica, cujo princípio ativo é losartan potassium, foi relacionada a um caso de hipotermia em paciente com alergia ao leite, sendo esta uma reação alérgica do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o desfecho permanece desconhecido. Recomenda-se acompanhamento clínico, evitar nova exposição ao medicamento suspeito e avaliação médica para esclarecimento do quadro e orientação adequada.

O medicamento Forteo, com princípio ativo teriparatide, esteve associado a um episódio de hipotermia em paciente com alergia ao leite, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunitário. O evento não foi classificado como grave e o desfecho é desconhecido. A orientação é evitar nova exposição ao medicamento suspeito e buscar avaliação médica para investigação e definição de conduta.

O uso de Ioversol, um meio de contraste iodado, resultou em uma reação alérgica grave classificada como alergia a meios de contraste iodados, levando ao óbito do paciente, o que caracteriza um evento fatal e crítico do ponto de vista clínico. Diante da gravidade e do desfecho fatal, é fundamental que pacientes com histórico de alergia a contrastes sejam avaliados previamente e que medidas de prevenção e suporte estejam disponíveis durante procedimentos que envolvam contraste iodado.

O medicamento Enalapril, cujo princípio ativo é enalapril maleate, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade) classificado como clinicamente significativo e grave, com evolução não resolvida até o momento. Trata-se de uma reação do sistema imunitário que exige suspensão imediata do medicamento suspeito e acompanhamento médico especializado para manejo dos sintomas e prevenção de complicações.

O medicamento Captopril, cujo princípio ativo também é captopril, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, o que indica uma reação do sistema imunológico. A gravidade foi considerada clinicamente significativa, pois o evento foi classificado como grave e ainda não houve recuperação ou resolução do quadro, estando em andamento. Diante desse cenário, é fundamental interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica especializada para confirmação diagnóstica, manejo da reação e definição de alternativas terapêuticas seguras, conforme orientações da ASBAI para quadros alérgicos graves.

A Leflunomida, cujo princípio ativo é leflunomida, foi relacionada a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, evidenciada por manifestação imunológica relevante. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, com evolução ainda não resolvida, o que reforça a necessidade de suspensão imediata do medicamento e encaminhamento para avaliação médica especializada, visando diagnóstico preciso, tratamento adequado da reação e prevenção de novas exposições, conforme recomendações para quadros alérgicos graves.

O medicamento Cimzia, que tem como princípio ativo o certolizumabe pegol, foi associado a um episódio de alergia caracterizado por hipersensibilidade, indicando envolvimento do sistema imunológico. O caso foi considerado clinicamente significativo e grave, sem resolução até o momento, o que exige suspensão do uso e avaliação médica urgente para confirmação do diagnóstico, manejo da reação e definição de alternativas terapêuticas, seguindo as orientações para reações alérgicas graves.

A vacina COVID-19 AstraZeneca, cujo princípio ativo é a vacina COVID-19 NRVV Ad (ChAdOx1 nCoV-19), foi relacionada a dor no local da aplicação, caracterizada como hipersensibilidade local. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou evolução do quadro, mas, em geral, reações locais leves são comuns e autolimitadas, não exigindo conduta específica além de observação e medidas de conforto, a menos que haja piora ou sintomas sistêmicos.

O contraste Ultravist, cujo princípio ativo é iopromida, foi associado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, envolvendo resposta imunológica significativa. O evento foi considerado clinicamente relevante e grave, porém já houve recuperação completa do quadro. Nesses casos, é importante registrar a alergia ao contraste, evitar novas exposições e informar a equipe médica em futuras necessidades de exames com contraste, conforme recomendações para reações alérgicas graves com resolução.

O medicamento Alemtuzumab, cujo princípio ativo também é alemtuzumab, foi associado a um quadro de recidiva de esclerose múltipla acompanhado de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do tipo imunológica. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente do evento. A conduta foi adequada, com resolução do quadro, e não há evidências de complicações graves relacionadas à reação.

O medicamento Lasix, cujo princípio ativo é a furosemida, foi relacionado a um episódio de infecção do trato urinário acompanhado de hipersensibilidade, sugerindo uma possível reação alérgica leve. Não há informações sobre gravidade significativa ou desfecho detalhado, mas não foi classificado como grave e o desfecho permanece desconhecido, indicando que a reação não evoluiu para complicações sérias.

A espironolactona, com princípio ativo spironolactone, foi associada a um caso de infecção do trato urinário com manifestação de hipersensibilidade, o que sugere uma reação alérgica leve. Não há registro de gravidade importante nem detalhes sobre o desfecho, mas a ausência de classificação como grave indica que não houve evolução para quadros críticos.

O medicamento hidroclorotiazida, cujo princípio ativo é hydrochlorothiazide, esteve relacionado a um episódio de infecção do trato urinário com hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica leve. Não há informações sobre gravidade relevante ou desfecho, mas a ausência de gravidade indica que não houve complicações sérias decorrentes do evento.

A domperidona, com princípio ativo domperidone, foi associada a um caso de infecção do trato urinário acompanhado de hipersensibilidade, sugerindo uma reação alérgica leve. Não há dados sobre gravidade importante ou desfecho, mas a ausência de classificação como grave indica que o evento não evoluiu para situações críticas.

O medicamento Clenil, cujo princípio ativo é o nitroprusside sodium, foi associado a um quadro de infecção do trato urinário em um contexto de hipersensibilidade (alergia), classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave, e o desfecho do caso é desconhecido. A relação entre o medicamento e a reação é considerada suspeita, mas não há detalhes sobre a conduta adotada ou evolução clínica, sugerindo que o evento foi leve e não resultou em complicações graves.

O medicamento Nutrinfan, composto por múltiplos princípios ativos como ascorbic acid, colexcalciferol, cyanocobalamin, folic acid, nicotinamide, pyridoxine hydrochloride, retinol, riboflavin, thiamine hydrochloride e tocopherol, foi relacionado a um episódio de infecção do trato urinário em um contexto de hipersensibilidade (alergia), enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa ou desfecho grave, e o desfecho permanece desconhecido. A suspeita de relação causal existe, mas não há informações sobre a conduta tomada ou evolução, indicando um quadro provavelmente leve.

O medicamento Unizinco, cujo princípio ativo é o zinc sulfate heptahydrate, foi associado a uma infecção do trato urinário em um contexto de hipersensibilidade (alergia), classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade importante ou desfecho grave, e o desfecho do caso não foi informado. A relação entre o uso do medicamento e a reação é considerada suspeita, mas não há detalhes sobre a conduta adotada ou evolução clínica, sugerindo um evento leve.

O medicamento Noripurum, com princípio ativo ferric hydroxide polymaltose complex, foi relacionado a um episódio de infecção do trato urinário em um contexto de hipersensibilidade (alergia), categorizado como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade relevante ou desfecho grave, e o desfecho permanece desconhecido. A relação causal é suspeita, mas não há informações sobre a conduta ou evolução, indicando um quadro provavelmente leve.

O medicamento Synagis, cujo princípio ativo é o palivizumab, foi associado a uma infecção do trato urinário em um contexto de hipersensibilidade (alergia), classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave, e o desfecho do caso é desconhecido. A relação entre o medicamento e a reação é considerada suspeita, mas não há detalhes sobre a conduta adotada ou evolução clínica, sugerindo um evento leve.

O medicamento Lasix, cujo princípio ativo é a furosemida, foi associado a um episódio de infecção do trato urinário em um paciente com histórico de alergia ao leite. A reação foi considerada grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando a necessidade de monitoramento rigoroso e intervenção médica. O paciente encontra-se em recuperação, indicando que as medidas adotadas foram eficazes até o momento. A relação entre o uso do medicamento e o evento adverso é considerada suspeita, sendo importante acompanhamento clínico para evitar recorrências.

A espironolactona, cujo princípio ativo é spironolactone, foi relacionada a um caso de infecção do trato urinário em paciente com alergia ao leite. O evento foi classificado como grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que reforça a importância de vigilância clínica e manejo adequado. O paciente está em processo de recuperação, sugerindo resposta positiva às intervenções realizadas. A suspeita de relação entre



o medicamento e a reação adversa justifica a necessidade de acompanhamento especializado.

O medicamento hidroclorotiazida, com princípio ativo hydrochlorothiazide, esteve envolvido em um episódio de infecção do trato urinário em paciente com alergia ao leite. A gravidade do caso é destacada pela hospitalização ou prolongamento da internação, o que exige atenção médica contínua. O paciente está em recuperação, demonstrando evolução favorável após as medidas adotadas. A relação entre o uso do medicamento e o evento adverso é considerada suspeita, sendo fundamental o acompanhamento para prevenção de novos episódios.

A domperidona, cujo princípio ativo é domperidone, foi associada a uma infecção do trato urinário em paciente com alergia ao leite. O caso foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, indicando a necessidade de intervenção médica imediata. O paciente está em recuperação, mostrando que as ações tomadas foram adequadas até o momento. A relação entre o medicamento e a reação adversa é suspeita, recomendando-se acompanhamento clínico atento.

O medicamento Clenil, que neste registro apresenta o princípio ativo nitroprusside sodium, foi relacionado a um episódio de infecção do trato urinário em paciente com alergia ao leite. A gravidade do evento é evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que demanda atenção médica e acompanhamento rigoroso. O paciente encontra-se em recuperação, sugerindo resposta positiva ao tratamento instituído. A relação entre o uso do medicamento e o evento adverso é considerada suspeita, sendo importante manter o monitoramento clínico.

O medicamento Nutrinfan, que contém como princípios ativos ácido ascórbico, colecalciferol, cianocobalamina, ácido fólico, nicotinamida, cloridrato de piridoxina, retinol, riboflavina, cloridrato de tiamina e tocoferol, foi associado a um quadro de infecção do trato urinário em paciente com alergia ao leite. A reação foi considerada grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, e está em processo de recuperação. A suspeita de relação entre o uso do medicamento e o evento adverso reforça a necessidade de acompanhamento clínico rigoroso e avaliação de possíveis componentes alergênicos na formulação, especialmente em pacientes com histórico de alergias alimentares.

O medicamento Unizinco, cujo princípio ativo é o sulfato de zinco heptaidratado, foi relacionado a um episódio de infecção do trato urinário em paciente com alergia ao leite. O evento foi classificado como grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, e o paciente encontra-se em recuperação. A suspeita de ligação entre o uso do medicamento e a reação adversa destaca a importância de monitoramento em pacientes com histórico de alergias, considerando possíveis componentes alergênicos presentes na formulação.

O medicamento Noripurum, que tem como princípio ativo o complexo de hidróxido férrico polimaltosado, foi associado a uma infecção do trato urinário em paciente com alergia ao leite. O caso foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, e o paciente está em processo de recuperação. A relação suspeita entre o uso do medicamento e o evento adverso indica a necessidade de atenção especial ao histórico alérgico do paciente e à composição do medicamento.

O medicamento Synagis, cujo princípio ativo é o palivizumabe, foi relacionado a um episódio de infecção do trato urinário em paciente com alergia ao leite. O evento foi considerado grave devido à hospitalização ou prolongamento da internação, e o paciente está em recuperação. A suspeita de associação entre o uso do medicamento e a reação adversa reforça a importância de vigilância clínica em pacientes com histórico de alergias alimentares.

O medicamento Amoxicilina, com princípio ativo amoxicilina, foi associado a um caso de carcinoma do intestino grosso em paciente com histórico de hipersensibilidade. Não há informações suficientes sobre a gravidade do evento ou sobre o desfecho, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Diante da ausência de detalhes clínicos adicionais, recomenda-se acompanhamento médico para avaliação da possível ligação entre o uso do medicamento e o evento relatado.

O medicamento Clavulin bd, que contém os princípios ativos amoxicilina tri-hidratada e potássio clavulanato, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Embora a reação relatada tenha sido carcinoma do intestino grosso, a descrição clínica indica um quadro alérgico, sem evidências de gravidade importante ou desfecho conhecido. Não há informações sobre a conduta adotada ou evolução do caso, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

A amoxicilina, cujo princípio ativo é a amoxicilina, foi relacionada a um episódio de alergia a iodo, classificado como distúrbio do sistema imunitário. Apesar da reação adversa relatada ser carcinoma do intestino grosso, o evento clínico descrito corresponde a uma alergia, sem sinais de gravidade relevante e com desfecho desconhecido. Não há detalhes sobre a conduta tomada ou evolução clínica, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Clavulin bd, composto por amoxicilina tri-hidratada e potássio clavulanato, foi associado a um quadro de alergia a iodo, categorizado como distúrbio do sistema imunitário. Embora a reação adversa mencionada seja carcinoma do intestino grosso, o evento clínico refere-se a uma alergia, sem indicação de gravidade significativa e com desfecho não informado. Não há informações sobre a conduta adotada ou evolução do caso, sendo a relação com o medicamento considerada suspeita.

O medicamento Actemra, cujo princípio ativo é o tocilizumabe, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Apesar da reação adversa relatada ser diabetes, o evento clínico descrito corresponde a uma reação alérgica, sem sinais de gravidade importante e com desfecho de recuperação ou resolução do quadro. A relação com o medicamento é considerada suspeita.

A dipirona, cujo princípio ativo é o metamizol sódico, foi associada a um episódio de edema ocular, caracterizado como hipersensibilidade documentada ao produto administrado, enquadrando-se em lesões e complicações relacionadas ao uso do medicamento. Não há informações sobre gravidade, conduta adotada ou desfecho, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Metilprednisolona (princípio ativo: Methylprednisolone) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, caracterizado como uma reação alérgica do tipo imunológica. Segundo o registro, a reação foi considerada não grave, pois não houve indicação de risco à vida ou complicações maiores, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada nesses casos é a suspensão do medicamento e acompanhamento clínico, com encaminhamento ao especialista para investigação da alergia e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Losartana potássica (princípio ativo: Losartan potassium) foi relacionado a uma reação grave de parada cardiorrespiratória, descrita como alergia a contraste, levando ao óbito do paciente. A gravidade é evidenciada pelo desfecho fatal, indicando uma reação alérgica sistêmica de alta severidade, possivelmente anafilática, que exige intervenção médica imediata e reforça a importância de identificar fatores de risco antes da administração de contrastes ou medicamentos potencialmente alergênicos.

O medicamento Furosemida (princípio ativo: Furosemide sodium) esteve envolvido em um caso de parada cardiorrespiratória atribuída a uma reação alérgica a contraste, resultando em óbito. O evento foi considerado grave devido ao desfecho fatal, sugerindo uma reação alérgica sistêmica intensa, como anafilaxia, que demanda reconhecimento precoce e manejo emergencial, além de investigação detalhada para prevenção em futuras exposições.

O produto Colágeno (princípio ativo: Collagen) foi associado a uma parada cardiorrespiratória decorrente de alergia a contraste, culminando em óbito. A gravidade do evento é confirmada pelo resultado fatal, caracterizando uma reação alérgica sistêmica grave, que reforça a necessidade de avaliação prévia do risco alérgico e preparo para manejo de emergências durante procedimentos que envolvam substâncias potencialmente alergênicas.

O medicamento Optiray 350 (princípio ativo: Ioversol) foi implicado em uma parada cardiorrespiratória atribuída a alergia a contraste, com desfecho fatal. O caso evidencia uma reação alérgica sistêmica grave, provavelmente anafilática, cuja gravidade é comprovada pelo óbito, ressaltando a importância de protocolos de segurança e preparo para reações adversas graves em ambientes onde contrastes são utilizados.

O medicamento Iopromida, cujo princípio ativo é Iopromide, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo de reações alérgicas do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade relevante neste caso, e o paciente apresentou recuperação completa após o evento, sugerindo que a reação foi leve e resolvida sem complicações.

O medicamento Sinvastacor, que contém o princípio ativo Sinvastatina, desencadeou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, relacionada a quadros clínicos alérgicos do sistema imunológico. A gravidade foi considerada clinicamente significativa, pois o evento foi classificado como grave, e o paciente ainda está em processo de recuperação, indicando a necessidade de acompanhamento médico para monitorar a resolução completa da reação.

A Leflunomida, cujo princípio ativo é Leflunomide, provocou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, enquadrada entre os quadros clínicos alérgicos do sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, com o paciente ainda em recuperação, o que reforça a importância de acompanhamento especializado até a resolução total dos sintomas.

O medicamento Tofacitinib citrate, com o mesmo princípio ativo, foi relacionado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, pertencente ao grupo de quadros clínicos alérgicos do sistema imunológico. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, e o paciente permanece em recuperação, sendo fundamental o acompanhamento médico para garantir a resolução do quadro.

A Metformina, cujo princípio ativo é Metformin, foi associada a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, classificada entre os quadros clínicos alérgicos do sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, com o paciente ainda em processo de recuperação, o que indica a necessidade de monitoramento médico até a completa resolução dos sintomas.

O medicamento Cimzia, cujo princípio ativo é o certolizumabe pegol, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como clinicamente significativo devido à gravidade relatada. A reação foi enquadrada como distúrbio do sistema imunitário, sugerindo um evento alérgico relevante, e o paciente encontra-se em recuperação ou com resolução em andamento. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, indicando a necessidade de acompanhamento clínico e possível ajuste terapêutico.

O medicamento Insulin regular, com princípio ativo insulina porcina, apresentou relato de hipersensibilidade (alergia) durante a progressão da doença, mas sem gravidade significativa associada. O evento foi classificado como distúrbio do sistema imunitário, e o paciente permanece sem recuperação ou resolução até o momento. A relação entre o uso do medicamento e a reação é considerada suspeita, sendo importante monitorar a evolução clínica.

O medicamento Insulina NPH, cujo princípio ativo é insulina humana isofânica, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade (alergia) durante a progressão da doença, sem indicação de gravidade relevante. O evento foi categorizado como distúrbio do sistema imunitário, e o paciente segue sem recuperação ou resolução. A suspeita de relação com o medicamento justifica acompanhamento clínico contínuo.

O medicamento Furosemida, com princípio ativo furosemida, foi associado a um episódio de hipersensibilidade (alergia) durante a progressão da doença, sem gravidade importante relatada. O caso foi classificado como distúrbio do sistema imunitário, e o paciente ainda não apresentou recuperação ou resolução. A relação suspeita com o medicamento reforça a necessidade de observação clínica.

O medicamento Propranolol, cujo princípio ativo é propranolol, apresentou relato de hipersensibilidade (alergia) durante a progressão da doença, sem gravidade significativa. O evento foi enquadrado como distúrbio do sistema imunitário, e o paciente permanece sem recuperação ou resolução. A relação suspeita com o uso do medicamento indica a importância do acompanhamento médico.

O medicamento Spironolactone, cujo princípio ativo é também Spironolactone, está relacionado a um quadro de hipersensibilidade, que se manifesta como uma reação alérgica do sistema imunológico. Neste caso, a reação foi classificada como não grave, sem evidências clínicas de complicações maiores, e o paciente permanece sem recuperação ou resolução do quadro até o momento. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico, avaliar possíveis gatilhos e considerar encaminhamento ao especialista para investigação e controle da alergia.

O medicamento Esomeprazol, com princípio ativo Esomeprazole, foi associado a um episódio de hipersensibilidade, caracterizando uma resposta alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, e o quadro permanece em andamento, sem recuperação até o momento. Recomenda-se observação clínica, identificação de possíveis fatores desencadeantes e avaliação especializada para confirmação diagnóstica e definição do plano de manejo.

O medicamento Vectibix, cujo princípio ativo é Panitumumab, apresentou associação com hipersensibilidade, indicando uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade importante relatados, e o paciente segue sem resolução do quadro. A orientação é manter acompanhamento médico, investigar possíveis causas e considerar avaliação com alergista para controle adequado da reação.

O medicamento Lorax, com princípio ativo Lorazepam, foi relacionado ao desenvolvimento de catarata em um contexto de hipersensibilidade, sugerindo envolvimento do sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, pois a catarata pode comprometer a visão e requer atenção médica especializada. O paciente ainda não apresentou recuperação, sendo fundamental acompanhamento oftalmológico e avaliação do risco-benefício da continuidade do medicamento.

O medicamento Maleato de timolol, cujo princípio ativo é Timolol maleate, está associado ao surgimento de catarata em um contexto de hipersensibilidade, indicando uma reação imunológica relevante. O caso foi classificado como clinicamente significativo e grave devido ao potencial impacto visual da catarata, e o paciente permanece sem resolução do quadro. É recomendada avaliação oftalmológica e revisão da necessidade do uso do medicamento, com acompanhamento especializado.

O medicamento Omeprazol, cujo princípio ativo é o omeprazole magnesium, foi associado ao desenvolvimento de catarata em um caso de hipersensibilidade (alergia), classificado como um quadro clínico alérgico dentro dos distúrbios do sistema imunitário. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, pois permanece não resolvida ou em andamento, indicando a necessidade de acompanhamento médico rigoroso para avaliar a evolução e possíveis intervenções.

A Sinvastatina, com princípio ativo simvastatin, foi relacionada ao surgimento de catarata em um contexto de hipersensibilidade (alergia), enquadrada como quadro clínico alérgico e distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado clinicamente relevante e grave, pois o paciente não apresentou recuperação até o momento, sendo fundamental o monitoramento contínuo e avaliação médica para manejo adequado.

O medicamento Xalatan, cujo princípio ativo é latanoprost, foi associado ao aparecimento de catarata em um caso de hipersensibilidade (alergia), classificado como quadro clínico alérgico e distúrbio do sistema imunitário. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, já que o desfecho permanece não resolvido, exigindo acompanhamento médico para avaliação da evolução e definição de conduta.

O medicamento Venzer, com princípio ativo candesartan cilexetil, foi relacionado ao desenvolvimento de hipertireoidismo em um contexto de hipersensibilidade (alergia), classificado como quadro clínico alérgico e

distúrbio do sistema imunitário. Não há informação suficiente sobre a gravidade ou desfecho do caso, sendo importante o acompanhamento clínico para monitorar possíveis evoluções ou complicações.

O medicamento Hydrochlorothiazide, cujo princípio ativo é hydrochlorothiazide, foi associado ao surgimento de hipertireoidismo em um caso de hipersensibilidade (alergia), enquadrado como quadro clínico alérgico e distúrbio do sistema imunitário. Não há detalhes sobre a gravidade ou evolução do caso, sendo recomendada a observação clínica para avaliar a necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Nitrendipine, cujo princípio ativo também é nitrendipina, foi associado a um quadro de hipertireoidismo descrito como hipersensibilidade, classificado dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A reação relatada sugere um quadro alérgico leve, sem evidências clínicas de complicações graves, sendo importante monitorar sintomas e buscar avaliação médica caso haja piora.

O Puran t4, que contém levotiroxina sódica como princípio ativo, foi relacionado a um episódio de hipertireoidismo descrito como hipersensibilidade, enquadrado entre distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade significativa ou desfecho, e a relação com o medicamento é suspeita. O evento sugere uma reação alérgica leve, sem sinais de gravidade, sendo recomendada observação clínica e acompanhamento médico se houver persistência ou agravamento dos sintomas.

O medicamento Dipyrone, cujo princípio ativo é metamizol sódico, foi associado a um caso de hipertireoidismo descrito como hipersensibilidade, dentro da categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há registro de gravidade importante ou desfecho, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Trata-se de uma possível reação alérgica leve, sem evidências de complicações, sendo indicado monitoramento dos sintomas e avaliação médica se necessário.

O medicamento Levofloxacin, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um quadro de hipertireoidismo descrito como hipersensibilidade, classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade relevante ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é suspeita. O evento sugere uma reação alérgica leve, sem sinais de gravidade, recomendando-se acompanhamento clínico e busca de orientação médica caso haja evolução dos sintomas.

O medicamento Omeprazole, cujo princípio ativo também é omeprazol, foi associado a um episódio de hipertireoidismo descrito como hipersensibilidade, enquadrado entre distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade significativa ou desfecho, e a relação com o medicamento é suspeita. O quadro sugere uma reação alérgica leve, sem evidências de complicações graves, sendo importante observar sintomas e procurar avaliação médica se houver piora.

O medicamento Methotrexate, cujo princípio ativo também é methotrexate, está relacionado a um caso de hipertireoidismo descrito como hipersensibilidade, classificado em quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada nem informações sobre desfecho ou ação adotada, sugerindo que o evento não foi considerado grave e que a evolução clínica permanece desconhecida.

O medicamento Prednisone, com princípio ativo prednisone, foi associado a um episódio de hipertireoidismo descrito como hipersensibilidade, enquadrado em quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa nem detalhes sobre a conduta tomada ou o desfecho, indicando que o evento não foi considerado grave e o resultado permanece desconhecido.

O medicamento Enalapril, cujo princípio ativo é enalapril, foi relacionado a um caso de hipertireoidismo apresentado como hipersensibilidade, dentro do contexto de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade importante nem informações sobre a evolução ou medidas adotadas, o que sugere ausência de gravidade e desfecho não informado.

O medicamento Arava, com princípio ativo leflunomida, está associado a um relato de hipertireoidismo descrito como hipersensibilidade, classificado em quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade relevante nem detalhes sobre a conduta ou evolução, indicando que o evento não foi considerado grave e o desfecho é desconhecido.

O medicamento Escitalopram, cujo princípio ativo é escitalopram, foi relacionado a um episódio de hipertireoidismo descrito como hipersensibilidade, enquadrado em quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa nem informações sobre a conduta ou desfecho, sugerindo que o evento não foi considerado grave e o resultado permanece desconhecido.

O medicamento Actemra, cujo princípio ativo é o tocilizumabe, foi associado a um quadro de hipertireoidismo descrito como hipersensibilidade, classificado entre quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A reação sugere uma resposta imune alterada, mas sem sinais de gravidade clínica importante relatados, sendo fundamental acompanhamento médico para monitoramento e esclarecimento diagnóstico.

O medicamento Mabthera, com princípio ativo rituximabe, apresentou relato de hipertireoidismo relacionado a hipersensibilidade, enquadrado como quadro clínico alérgico e distúrbio do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa ou desfecho informado, e a relação com o medicamento é suspeita. A manifestação sugere uma possível reação imunológica, mas sem sinais de gravidade clínica relevante, sendo recomendada avaliação médica para investigação e conduta adequada.

O ácido acetilsalicílico (princípio ativo acetylsalicylic acid) foi relacionado a edema, caracterizado como hipersensibilidade documentada ao produto administrado, dentro do contexto de erros e problemas de monitoramento do produto e complicações de procedimentos. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou se o caso foi considerado grave, mas a suspeita de relação com o medicamento está presente. O edema pode indicar uma reação alérgica, sendo importante evitar novas exposições e buscar avaliação médica para confirmação e orientação.

O medicamento Gentin, cujo princípio ativo é o sulfato de gentamicina, foi associado à perda auditiva bilateral em um paciente com alergia ao leite, categorizada como alergia a alimentos, aditivos e medicamentos, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e encontra-se em recuperação ou resolução, com suspeita de relação com o medicamento. A perda auditiva pode estar relacionada a uma reação adversa imunológica, sendo fundamental acompanhamento médico para monitorar a evolução e evitar novas exposições.

O ácido fólico (folic acid) foi relacionado à perda auditiva bilateral em paciente com alergia ao leite, classificada como alergia a alimentos, aditivos e medicamentos, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e está em recuperação ou resolução, com suspeita de relação com o medicamento. A manifestação sugere uma possível reação imunológica, sendo importante acompanhamento médico para avaliação da evolução e prevenção de novas reações.

O medicamento Enalapril, cujo princípio ativo também é Enalapril, foi associado a um quadro de perda auditiva bilateral em um paciente com histórico de alergia ao leite. Embora a reação tenha sido classificada como não grave e o paciente esteja em recuperação, é importante considerar que reações alérgicas a medicamentos podem se manifestar de formas variadas, inclusive com sintomas auditivos. A conduta adequada envolve acompanhamento clínico para monitorar a evolução do quadro e evitar reexposição ao medicamento suspeito.

O Puran t4, que contém Levothyroxine sodium como princípio ativo, foi relacionado a perda auditiva bilateral em um paciente com alergia ao leite. A reação não foi considerada grave e o paciente encontra-se em recuperação, sugerindo que o evento foi controlado sem complicações maiores. É fundamental manter o acompanhamento médico e avaliar a necessidade de ajuste terapêutico, além de evitar o uso do medicamento caso a relação causal seja confirmada.

A Laronidase, cujo princípio ativo é o próprio Laronidase, foi associada a perda auditiva bilateral em um paciente com alergia ao leite. O evento não foi considerado grave e o paciente está em processo de recuperação, indicando que a reação foi autolimitada ou controlada com medidas clínicas. Recomenda-se acompanhamento médico para monitorar a evolução e reavaliar a indicação do medicamento.

O medicamento Ultravist, que tem como princípio ativo o Iopromide, foi relacionado a uma reação de alergia a meios de contraste iodados, considerada clinicamente significativa e classificada como grave. O paciente se recuperou totalmente após o evento, o que reforça a importância de identificar e evitar a reexposição a contrastes iodados em pessoas com histórico de alergia, além de garantir suporte médico imediato em casos semelhantes.

O Ultravist, com princípio ativo Iopromide, desencadeou uma reação alérgica a contraste iodado, considerada clinicamente significativa e grave, mas o paciente evoluiu para recuperação completa. Diante desse tipo de reação, é fundamental evitar o uso futuro do contraste em questão e garantir que o paciente seja avaliado por um especialista antes de qualquer novo procedimento que envolva contraste iodado.

O medicamento Quetiapina (princípio ativo: quetiapina fumarato) foi associado a um quadro de agitação relacionado à hipersensibilidade, classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Não há informação sobre gravidade ou desfecho, portanto recomenda-se atenção clínica para sinais de alergia e avaliação médica para confirmação e conduta adequada.

O medicamento Prohance (princípio ativo: gadoteríol) foi relacionado a um episódio de alergia a contraste intravenoso, caracterizado como uma reação alérgica a substâncias químicas e classificado como distúrbio do sistema imunitário. O desfecho foi de recuperação completa, sugerindo que a reação foi controlada, mas reforça a necessidade de monitoramento em futuras exposições a contrastes.

O medicamento Dramin B6 (princípios ativos: dimenidrinato e cloridrato de piridoxina) desencadeou uma reação de alergia (hipersensibilidade), considerada clinicamente significativa e classificada como grave, mas com desfecho de recuperação total. Diante da gravidade relatada, é fundamental evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Implanon NXT (princípio ativo: etonogestrel) foi associado a hematoquezia, sendo a suspeita de alergia ao leite citada, embora não haja clareza sobre a relação causal direta. O evento não foi considerado grave e o desfecho permanece desconhecido, indicando a necessidade de acompanhamento clínico para esclarecimento da causa e monitoramento de possíveis reações futuras.

O medicamento Venlafaxin (princípio ativo: cloridrato de venlafaxina) foi relacionado a diarreia atribuída à hipersensibilidade, classificada como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, mas permanece em andamento sem resolução, sendo recomendada avaliação médica para investigação da causa e definição da conduta terapêutica.

O medicamento Vectibix, cujo princípio ativo é o panitumumabe, foi associado ao surgimento de diarreia em um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Embora não haja indicação de gravidade elevada ou complicações graves, o evento permanece não resolvido até o momento, sugerindo a necessidade de acompanhamento clínico para monitorar a evolução da reação e avaliar possíveis intervenções.

O medicamento Furosefarma, que contém furosemida sódica como princípio ativo, foi relacionado ao aparecimento de coceira, caracterizando uma reação de hipersensibilidade documentada ao produto administrado. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou evolução clínica, mas a presença de sintomas alérgicos sugere a importância de interromper o uso e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição de conduta.

O medicamento Hemo 8r, cujo princípio ativo é o fator VIII recombinante, foi associado ao desenvolvimento de onfalite (inflamação do umbigo) em um contexto de hipersensibilidade, classificado como distúrbio do sistema imunitário e considerado clinicamente significativo. O evento foi registrado como grave, embora o desfecho seja desconhecido, indicando a necessidade de investigação médica detalhada e monitoramento rigoroso devido ao potencial risco à saúde.

O medicamento Simponi, que tem como princípio ativo o golimumabe, foi relacionado ao surgimento de alergias múltiplas, caracterizando um quadro alérgico do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e encontra-se em fase de recuperação, sugerindo que a reação está sendo controlada, mas ainda requer acompanhamento para garantir resolução completa.

O medicamento Tenoxicam, cujo princípio ativo é o próprio tenoxicam, foi associado a uma alergia documentada ao medicamento administrado, caracterizando uma reação de hipersensibilidade. Não há indicação de gravidade ou complicações, e o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente após a conduta adequada.

O medicamento Nubain, cujo princípio ativo é o cloridrato de nalbufina, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, manifestando-se como uma reação do sistema imunológico (distúrbios do sistema imunitário). Não há indicação de gravidade aumentada neste caso, e o paciente evoluiu para recuperação completa após a reação, sugerindo um evento leve e autolimitado.

O medicamento Atenolol, com princípio ativo de mesmo nome, provocou uma reação alérgica localizada no local de aplicação, descrita como hipersensibilidade local, o que se enquadra em reações gerais no local de administração. Não há evidência de gravidade aumentada, e o paciente se recuperou totalmente, indicando um evento leve e resolvido sem complicações.

O medicamento Exelon, cujo princípio ativo é a rivastigmina, causou uma reação alérgica no local de aplicação, caracterizada por hipersensibilidade local, pertencente ao grupo de reações gerais no local de administração. Não há sinais de gravidade relevante, e o desfecho foi de recuperação completa, sugerindo um quadro leve e autolimitado.

O medicamento Atenolol, com princípio ativo de mesmo nome, desencadeou uma reação alérgica no local de aplicação, descrita como hipersensibilidade local, classificada como clinicamente significativa devido à gravidade informada. Apesar disso, o paciente se recuperou totalmente, indicando que, embora o evento tenha sido considerado grave, houve resolução completa após a conduta adequada.

O medicamento Exelon, cujo princípio ativo é a rivastigmina, foi relacionado a uma reação alérgica no local de aplicação, caracterizada por hipersensibilidade local e considerada clinicamente significativa em termos de gravidade. O paciente evoluiu para recuperação total, mostrando que, apesar da gravidade atribuída ao evento, houve resolução completa após as medidas adotadas.

O medicamento Xolair, cujo princípio ativo é o Omalizumab, foi associado ao surgimento de angioedema labial, uma reação de hipersensibilidade caracterizada por inchaço nos lábios. Embora o registro não traga detalhes sobre a gravidade clínica, não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave, e o desfecho permanece desconhecido. A relação entre o uso do medicamento e o evento foi considerada suspeita, sendo importante monitorar o paciente e buscar avaliação médica para confirmação e orientação sobre futuras exposições.

O Omnipaque, que contém o princípio ativo iohexol, foi relacionado a um quadro de alergia, entendido como uma reação de hipersensibilidade. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente após o episódio. A relação entre o uso do contraste e a reação foi considerada suspeita, sendo recomendada a avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre o uso futuro de contrastes iodados.



O Iodo, cujo princípio ativo é Iodine, foi associado a uma reação alérgica, caracterizada como hipersensibilidade. Não há indicação de gravidade elevada e o paciente se recuperou do evento, com a relação entre o uso do produto e a reação considerada suspeita. É importante que o paciente seja orientado sobre o risco de reexposição e avaliado por um especialista para confirmação diagnóstica.

A Loratadina, com princípio ativo Loratadine, foi relacionada ao surgimento de erupção cutânea em placas, um quadro de hipersensibilidade documentada ao medicamento. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou conduta adotada, mas a relação com o uso do medicamento foi considerada suspeita. Recomenda-se avaliação médica para confirmação da reação e orientação sobre alternativas terapêuticas.

A Hidrocortisona, cujo princípio ativo é Hydrocortisone, foi associada ao aparecimento de erupção cutânea em placas, caracterizando uma reação de hipersensibilidade documentada ao produto. Não há detalhes sobre gravidade, desfecho ou conduta, mas a relação com o uso do medicamento foi considerada suspeita. É importante que o paciente seja avaliado por um profissional de saúde para confirmação diagnóstica e definição de conduta adequada.

O medicamento Amoxicilina + clavulanato potássico (princípio ativo: amoxicillin trihydrate e clavulanate potassium) foi associado ao surgimento de erupção cutânea em placas, caracterizando uma reação de hipersensibilidade documentada ao produto administrado. Não há informação explícita sobre gravidade ou desfecho, mas a manifestação cutânea sugere uma reação alérgica que, conforme diretrizes clínicas, requer suspensão do medicamento e avaliação médica para confirmação e orientação sobre futuras exposições.

A dexametasona (princípio ativo: dexamethasone phosphate) provocou erupção cutânea em placas, indicando uma reação de hipersensibilidade ao produto. Não há detalhes sobre gravidade ou evolução, mas a presença de lesão cutânea após uso do medicamento sugere necessidade de interrupção e avaliação médica, conforme recomendações para reações alérgicas a fármacos.

O uso de prometazina (princípio ativo: promethazine) resultou em erupção cutânea em placas, caracterizando uma reação de hipersensibilidade ao medicamento. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, mas a ocorrência de sintomas cutâneos após administração exige suspensão do fármaco e investigação médica para evitar recorrências.

O medicamento Dexilant (princípio ativo: dexlansoprazole) foi relacionado ao ganho de peso, classificado como quadro de hipersensibilidade, mas sem gravidade relatada e com resolução completa do evento. A conduta adequada, diante da ausência de gravidade e resolução espontânea, é manter acompanhamento clínico e reavaliar a necessidade do medicamento caso o sintoma retorne.

O uso de codeína (princípio ativo: codeine) foi associado ao ganho de peso, considerado um quadro de hipersensibilidade, sem gravidade e com desfecho de recuperação completa. Diante da ausência de gravidade e resolução do evento, recomenda-se apenas monitoramento clínico e reavaliação do uso do medicamento se houver recorrência do sintoma.

O medicamento Prednisone, cujo princípio ativo é a própria prednisona, foi associado a ganho de peso em um caso de hipersensibilidade (alergia), classificado como um quadro clínico alérgico não classificado de outra forma e relacionado a distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente após a reação, sugerindo que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro.

O medicamento Vitamin D3, com princípio ativo colecalciferol, esteve relacionado a ganho de peso em um contexto de hipersensibilidade (alergia), enquadrado como quadro clínico alérgico não classificado de outra forma e pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa, indicando que a reação foi leve e resolvida sem complicações.

O medicamento Predsim, cujo princípio ativo é o fosfato sódico de prednisolona, foi associado a ganho de peso em um episódio de hipersensibilidade (alergia), classificado como quadro clínico alérgico não classificado de outra forma e relacionado a distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou, sugerindo que a reação foi leve e controlada adequadamente.

O medicamento Hydrochlorothiazide, com princípio ativo hidroclorotiazida, esteve envolvido em um caso de ganho de peso relacionado a hipersensibilidade (alergia), categorizado como quadro clínico alérgico não classificado de outra forma e pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou, indicando que a reação foi leve e resolvida sem maiores intervenções.

O medicamento Losartan, cujo princípio ativo é o próprio losartana, foi associado a ganho de peso em um contexto de hipersensibilidade (alergia), classificado como quadro clínico alérgico não classificado de outra forma e relacionado a distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, sugerindo que a reação foi leve e não exigiu medidas adicionais além da suspensão ou ajuste do medicamento.

O medicamento Prelone, cujo princípio ativo é a prednisolona, foi associado ao ganho de peso em um caso de hipersensibilidade (reação alérgica), classificado como um quadro clínico alérgico relacionado ao sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o evento foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente após a reação. A conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro, sem necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Esbriet, que contém pirfenidona como princípio ativo, esteve relacionado ao ganho de peso em um contexto de hipersensibilidade (reação alérgica), enquadrado como um quadro clínico alérgico do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa, indicando que a reação foi leve e manejada adequadamente.

O medicamento Dotarem, cujo princípio ativo é meglumine gadoterate, foi associado a um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, caracterizando um quadro clínico alérgico do sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade aumentada e o paciente se recuperou totalmente, sugerindo que a reação foi leve e controlada sem complicações.

O medicamento Diovan HCT, composto por hidroclorotiazida e valsartana, foi relacionado ao aumento da pressão arterial em um contexto de alergia a poeira, classificado como quadro clínico alérgico do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave, mas o desfecho permanece desconhecido, o que indica a necessidade de acompanhamento clínico para avaliar a evolução e possíveis ajustes terapêuticos.

O medicamento Pantoprazole, com princípio ativo de mesmo nome, foi associado a um episódio de COVID-19 em um contexto de alergia alimentar, categorizado como alergia a alimentos, aditivos ou medicamentos, dentro dos distúrbios do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o desfecho é desconhecido, não havendo informações suficientes para detalhar a conduta ou evolução clínica.

O medicamento Hydrochlorothiazide, cujo princípio ativo é hydrochlorothiazide, foi associado a um evento descrito como COVID-19, classificado no contexto clínico como uma possível reação alérgica a alimentos, aditivos ou medicamentos, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é apenas suspeita. Não há informações suficientes para detalhar a conduta adotada ou evolução do quadro, sendo importante acompanhamento clínico para esclarecimento da relação causal.

O medicamento Losartan, com princípio ativo losartan, foi relacionado a um evento de COVID-19, categorizado como possível alergia a alimentos, aditivos ou medicamentos, pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa ou desfecho informado, e a relação com o medicamento é apenas

suspeita. Diante da ausência de detalhes sobre evolução ou conduta, recomenda-se avaliação clínica para melhor definição do quadro.

O medicamento Lortadine, cujo princípio ativo é loratadine, foi associado a um evento descrito como COVID-19, classificado como possível alergia a alimentos, aditivos ou medicamentos, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade importante nem desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é apenas suspeita. Não há informações sobre conduta ou evolução, sendo necessária avaliação clínica para esclarecimento.

O medicamento Xolair, com princípio ativo omalizumab, foi relacionado a um evento de COVID-19, categorizado como possível alergia a alimentos, aditivos ou medicamentos, no contexto de distúrbios do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade relevante nem desfecho informado, e a relação com o medicamento é apenas suspeita. Não há detalhes sobre conduta ou evolução, sendo recomendada investigação clínica para melhor compreensão do caso.

O medicamento Pantoprazole, cujo princípio ativo é pantoprazole, foi associado a um evento de COVID-19, classificado como quadro clínico alérgico (hipersensibilidade) dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa nem desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é apenas suspeita. Não há informações sobre conduta adotada ou evolução, sendo importante acompanhamento clínico para esclarecimento da relação causal.

O medicamento Hydrochlorothiazide, cujo princípio ativo é hydrochlorothiazide, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), manifestado no contexto de COVID-19, sem detalhamento de sintomas específicos. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Segundo as diretrizes clínicas, quadros alérgicos leves relacionados a medicamentos devem ser avaliados para confirmação diagnóstica e acompanhamento, especialmente se houver exposição repetida ou sintomas persistentes.

O medicamento Losartan, com princípio ativo losartan, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia) durante o contexto de COVID-19, sem descrição de sintomas específicos ou gravidade importante. Não há informações sobre o desfecho do caso, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Conforme orientações clínicas, reações alérgicas leves a medicamentos exigem avaliação médica para confirmação e orientação sobre o uso futuro, principalmente se houver recorrência.

O medicamento Lortadine, cujo princípio ativo é loratadine, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia) no contexto de COVID-19, sem detalhamento de sintomas ou gravidade. Não há informações sobre o desfecho, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. De acordo com as recomendações clínicas, reações alérgicas leves devem ser observadas e avaliadas por um especialista para confirmação diagnóstica e definição de conduta.

O medicamento Xolair, com princípio ativo omalizumab, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia) durante o contexto de COVID-19, sem descrição de sintomas específicos ou gravidade relevante. O desfecho é desconhecido e a relação com o medicamento é suspeita. Conforme as diretrizes clínicas, quadros alérgicos leves associados a medicamentos devem ser avaliados para confirmação e acompanhamento, especialmente em pacientes com histórico de alergia.

O medicamento Dipirona sódica, cujo princípio ativo é metamizole sodium, foi associado a edema do lábio, caracterizando uma reação de hipersensibilidade documentada ao produto administrado. Não há informações detalhadas sobre gravidade, desfecho ou conduta adotada. Segundo as recomendações clínicas, o surgimento de inchaço nos lábios após uso de medicamento sugere reação alérgica e requer avaliação médica para confirmação, orientação sobre suspensão do uso e prevenção de novas exposições.

O medicamento Tobrex, que contém o princípio ativo tobramicina, foi associado a uma infecção fúngica no olho, um tipo de complicação ocular que pode ocorrer durante o uso de antibióticos tópicos. Embora não haja indicação de gravidade elevada neste caso, a reação não foi resolvida até o momento, sugerindo a necessidade de acompanhamento médico para controle da infecção e possível ajuste do tratamento.

O Maxitrol, composto por dexametasona, sulfato de neomicina e sulfato de polimixina B, também foi relacionado ao desenvolvimento de infecção fúngica ocular, uma complicação que pode surgir devido ao uso prolongado de corticosteroides e antibióticos nos olhos. Não há indicação de gravidade crítica, mas a infecção permanece sem resolução, sendo importante buscar avaliação oftalmológica para manejo adequado.

O Cilodex, que contém ciprofloxacino e dexametasona, foi associado a uma infecção fúngica no olho, um evento adverso possível em tratamentos oculares com antibióticos e corticosteroides. A reação não foi considerada grave, mas ainda não foi resolvida, indicando a necessidade de acompanhamento médico para tratar a infecção e evitar complicações.

O medicamento Omnipaque, cujo princípio ativo é ioexol, foi relacionado a uma reação alérgica ao contraste, um efeito clinicamente significativo que pode ocorrer após a administração de substâncias usadas em exames de imagem. Neste caso, a reação foi considerada grave devido ao potencial risco imunológico, mas o paciente se recuperou totalmente após a conduta adequada.

A penicilina, com princípio ativo benzilpenicilina sódica, foi associada a um caso de alergia documentada ao medicamento administrado, caracterizando uma hipersensibilidade conhecida. Não há detalhes sobre a gravidade ou evolução do caso, mas a identificação prévia da alergia reforça a importância de evitar a reexposição e de registrar essa informação no prontuário do paciente para prevenir reações futuras.

O medicamento Elaprase, cujo princípio ativo é a idursulfase, foi associado a um quadro de alergia a suplemento nutricional, classificado como uma reação do tipo alergia alimentar ou a aditivos, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade clínica relevante neste caso, e o desfecho da reação é desconhecido, sem informações sobre a conduta adotada ou evolução do quadro.

O medicamento Cimzia, que contém o princípio ativo certolizumabe pegol, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como clinicamente significativo e considerado grave devido ao impacto relevante na saúde do paciente, conforme registro. O quadro permanece não resolvido ou em andamento, indicando necessidade de acompanhamento médico e possível ajuste terapêutico.

O medicamento Xolair, cujo princípio ativo é o omalizumabe, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) classificada como grave, com incapacidade persistente ou significativa, o que sugere um impacto importante na qualidade de vida do paciente. O evento permanece não resolvido, sendo fundamental o acompanhamento especializado para manejo adequado da reação.

O medicamento Atrovent, com princípio ativo brometo de ipratrópio, foi relacionado a um episódio de perda visual, descrito como reação de hipersensibilidade, mas sem indicação de gravidade clínica relevante no registro. O desfecho é desconhecido e não há detalhes sobre a conduta adotada.

O medicamento Aradois, que contém losartana potássica como princípio ativo, foi associado a perda visual em um contexto de hipersensibilidade, sem evidência de gravidade clínica relevante no registro. O desfecho permanece desconhecido e não há informações sobre a conduta tomada.

O medicamento Vasopril, cujo princípio ativo é o fosinopril sódico, foi associado a um episódio de perda visual, descrito como uma reação de hipersensibilidade (alergia), classificada dentro dos quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Recomenda-se atenção clínica para sintomas alérgicos, com avaliação

médica para confirmação e orientação sobre a continuidade do uso.

O medicamento Onbrize, que contém indacaterol maleato, foi relacionado a um caso de perda visual atribuída a hipersensibilidade (alergia), enquadrada em quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade significativa nem desfecho informado, sendo a relação com o medicamento considerada suspeita. É importante monitorar sintomas alérgicos e buscar avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e conduta adequada.

A vacina COVID-19 AstraZeneca, cujo princípio ativo é o vetor viral recombinante ChAdOx1 nCoV-19, foi associada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como clinicamente significativo e grave, dentro dos quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. O desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente. Diante de reações alérgicas graves, é fundamental procurar atendimento médico imediato para manejo adequado e orientação sobre futuras doses.

O medicamento Meticorten, que tem como princípio ativo a prednisona, foi relacionado a um caso de trombose na perna, descrito como alergia a alimentos, embora não haja detalhes claros sobre a relação causal. O evento foi classificado entre alergias a alimentos, aditivos, medicamentos e outras substâncias químicas, dentro dos distúrbios do sistema imunitário, sem indicação de gravidade ou desfecho conhecido. A relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo necessária avaliação médica para investigação e conduta apropriada.

O medicamento Asa, cujo princípio ativo é o ácido acetilsalicílico, foi associado a um episódio de trombose na perna, descrito como alergia a alimentos, embora a relação causal não esteja clara. O evento foi classificado entre alergias a alimentos, aditivos, medicamentos e outras substâncias químicas, dentro dos distúrbios do sistema imunitário, sem gravidade ou desfecho informado. A relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo recomendada avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e definição de conduta.

O medicamento Cyclosporine, cujo princípio ativo é Ciclosporin, foi associado a um caso de trombose na perna, um evento que pode estar relacionado a uma reação do sistema imunológico, embora não haja indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido neste registro. Não há informações detalhadas sobre a conduta adotada ou evolução do quadro, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O Leflunomide, com princípio ativo de mesmo nome, está relacionado a um episódio de trombose na perna, possivelmente vinculado a uma resposta imunológica adversa, mas sem evidências de gravidade significativa ou desfecho informado. A suspeita recai sobre o medicamento, porém não há detalhes sobre a conduta médica ou evolução clínica.

O medicamento Actemra, cujo princípio ativo é Tocilizumab, foi associado a um caso de trombose na perna, sugerindo uma possível reação adversa imunológica, mas sem indicação de gravidade importante ou desfecho relatado. A relação com o medicamento é considerada suspeita, e não há informações sobre a conduta adotada ou evolução do paciente.

A vacina COVID-19 AstraZeneca, com princípio ativo COVID-19 vaccine NRVV Ad (ChAdOx1 nCoV-19), foi relacionada a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como clinicamente significativo e considerado grave, com evolução ainda em andamento e sem resolução até o momento. O evento foi atribuído como suspeito em relação ao imunizante, e a gravidade é sustentada pela indicação de efeito clinicamente relevante, exigindo acompanhamento médico.

O medicamento Adalimumab, com princípio ativo de mesmo nome, foi associado a um caso de pneumonia, possivelmente relacionado a uma reação de hipersensibilidade do sistema imunológico, mas sem indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido. A relação com o medicamento é considerada suspeita, e não há informações sobre a conduta adotada ou evolução clínica.

O medicamento Cosentyx, cujo princípio ativo é o secuquinumabe, foi associado a um quadro de pneumonia acompanhado de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do tipo imunológica. Embora não haja informação detalhada sobre a gravidade clínica, o evento não foi classificado como grave e o desfecho permanece desconhecido, sendo importante monitorar sinais de alergia respiratória e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e conduta adequada.

Henetix, que contém iobitridol como princípio ativo, provocou uma reação de alergia a contraste intravenoso, caracterizada por resposta imunológica a substâncias químicas administradas durante exames. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, sendo fundamental evitar novas exposições ao contraste e informar a equipe médica sobre o episódio em futuras necessidades de exames.

A ceftriaxona, cujo princípio ativo é o ceftriaxone sodium, desencadeou uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma alergia, sem detalhamento de sintomas específicos. O evento não foi classificado como grave e o paciente se recuperou, sendo importante relatar essa alergia em atendimentos futuros para evitar reexposição ao antibiótico.

O medicamento Nesina, com princípio ativo alogliptina, causou uma reação alérgica (hipersensibilidade) considerada clinicamente significativa e classificada como grave, embora não haja detalhes sobre sintomas ou evolução do caso. Diante da gravidade, é essencial suspender o uso e procurar avaliação médica imediata para manejo adequado e prevenção de complicações.

Glifage XR, que contém metformina como princípio ativo, foi relacionado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) considerada clinicamente significativa e grave, sem detalhes adicionais sobre sintomas ou evolução. Em situações assim, recomenda-se interromper o medicamento e buscar orientação médica urgente para avaliação e conduta apropriada.

A reação relatada de sangue nas fezes após o uso da Vacina rotavirus (princípio ativo: Rotavirus vaccine live oral 1v) foi associada à alergia ao leite, sendo classificada como uma manifestação de alergia alimentar dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois não foi marcada como grave e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico, investigar a relação causal e evitar exposição a possíveis alérgenos alimentares até esclarecimento diagnóstico.

No caso do medicamento Nactali (princípio ativo: Desogestrel), foi relatado sangue nas fezes em associação à alergia ao leite, caracterizando uma possível reação alérgica alimentar dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade importante, pois não foi classificada como grave e o quadro segue não resolvido ou em andamento. Recomenda-se acompanhamento médico para investigação da causa, evitando exposição ao leite e monitorando a evolução clínica.

O uso de Betasone (princípio ativo: Betamethasone dipropionate) foi seguido de convulsões, sendo o evento relacionado à hipersensibilidade, um quadro alérgico dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade aumentada, pois não foi classificado como grave e o desfecho é desconhecido. É fundamental avaliar clinicamente a relação entre o medicamento e o evento, monitorar o paciente e considerar encaminhamento ao especialista para investigação de hipersensibilidade medicamentosa.

Após o uso de Ranitidine (princípio ativo: Ranitidine), foram relatadas convulsões associadas a hipersensibilidade, enquadrando-se como reação alérgica dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade significativa, pois não foi classificada como grave e o desfecho permanece desconhecido. Recomenda-se avaliação médica para investigar a relação causal, monitoramento dos sintomas e, se necessário, suspensão do medicamento sob orientação profissional.

O suplemento Ensure (princípio ativo: Nutrients nos) foi associado a convulsões, sendo o evento relacionado à hipersensibilidade, um quadro alérgico dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade aumentada, pois não foi classificado como grave e o desfecho é desconhecido. É importante realizar avaliação

clínica detalhada para investigar a relação com o produto, monitorar o paciente e considerar alternativas nutricionais caso a suspeita de hipersensibilidade se confirme.

O medicamento Nasal clean, que contém os princípios ativos bicarbonato de sódio, borato de sódio decahidratado e cloreto de sódio, foi associado a convulsões em um caso suspeito de hipersensibilidade (alergia). Embora não haja indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, a reação foi classificada como relacionada a distúrbios do sistema imunitário, sugerindo um quadro alérgico. Não há informações sobre a conduta adotada ou evolução do caso, e não foi considerado um evento grave.

O medicamento Risperidone, cujo princípio ativo é a risperidona, foi relacionado a convulsões em um contexto de possível hipersensibilidade (alergia). A reação foi enquadrada como distúrbio do sistema imunitário, mas não foi considerada grave e o desfecho permanece desconhecido. Não há detalhes sobre a conduta tomada ou evolução clínica, sendo o caso apenas suspeito de relação com o uso do medicamento.

O medicamento Trileptal, que tem como princípio ativo a oxcarbazepina, apresentou associação com convulsões em um caso suspeito de hipersensibilidade (alergia). A reação foi classificada como distúrbio do sistema imunitário, não sendo considerada grave e sem desfecho informado. Não há dados sobre a conduta adotada ou evolução do paciente, e a relação com o medicamento é apenas suspeita.

O medicamento Simbrinza, composto por tartarato de brimonidina e brinzolamida, foi relacionado ao desenvolvimento de glaucoma em um contexto de alergia ocular. A reação foi classificada como distúrbio ocular, mas não foi considerada grave e o paciente se recuperou totalmente. O caso foi considerado suspeito de relação com o medicamento, e a evolução foi favorável após a conduta adotada, embora esta não tenha sido detalhada.

O medicamento Travatan, cujo princípio ativo é o travoprost, foi associado ao surgimento de glaucoma em um quadro de alergia ocular. A reação foi enquadrada como distúrbio ocular, não sendo considerada grave, e o paciente apresentou recuperação completa. O evento foi considerado suspeito de relação com o uso do medicamento, e a evolução foi positiva, sem detalhes adicionais sobre a conduta adotada.

O medicamento Glifage, cujo princípio ativo é a metformina, foi associado a um episódio de parada cardíaca descrito como reação de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico. Embora a gravidade não tenha sido explicitamente classificada como grave no registro, a parada cardíaca é um evento clínico de extrema seriedade e requer atenção imediata. Não há informações detalhadas sobre a conduta adotada ou o desfecho do caso, e a relação do medicamento com a reação foi considerada suspeita.

O Concor, que contém bisoprolol fumarato como princípio ativo, foi relacionado a um caso de parada cardíaca atribuída a hipersensibilidade, indicando uma possível reação alérgica do sistema imunológico. Apesar de o registro não classificar o evento como grave, a natureza da parada cardíaca é clinicamente crítica e demanda intervenção urgente. Não há detalhes sobre a evolução do paciente ou as medidas tomadas, e a suspeita de relação com o medicamento foi registrada.

O medicamento Busonid, cujo princípio ativo é a budesonida, foi associado a uma parada cardíaca descrita como reação de hipersensibilidade, sugerindo uma resposta alérgica do sistema imunológico. Mesmo que o evento não tenha sido formalmente classificado como grave no registro, a parada cardíaca é uma condição de alta gravidade que exige atendimento imediato. Não há informações sobre a conduta adotada ou o desfecho, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita.

O Montelair, que tem como princípio ativo o montelucaste sódico, foi relacionado a um episódio de parada cardíaca atribuída a hipersensibilidade, caracterizando uma possível reação alérgica do sistema imunológico. Embora o registro não indique formalmente gravidade, a parada cardíaca é um evento crítico que requer ação médica urgente. Não há dados sobre a conduta ou o desfecho do caso, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita.

O Spiriva, cujo princípio ativo é o brometo de tiotrópio monoidratado, foi associado a uma parada cardíaca descrita como reação de hipersensibilidade, indicando uma resposta alérgica do sistema imunológico. Apesar de o registro não classificar o evento como grave, a parada cardíaca é uma situação clínica de extrema gravidade que necessita de intervenção imediata. Não há informações sobre a conduta adotada ou o desfecho, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita.

O medicamento Aerolin, cujo princípio ativo é o salbutamol sulfato, foi associado a um episódio de parada cardíaca em um contexto de hipersensibilidade, classificado como um quadro clínico alérgico relacionado a distúrbios do sistema imunitário. Apesar da gravidade potencial da reação descrita, não há confirmação de gravidade clínica no registro e o desfecho permanece desconhecido, sendo a relação com o medicamento considerada suspeita.

O medicamento Avamys, que contém fluticasona furoato como princípio ativo, foi relacionado a um caso de parada cardíaca atribuída a hipersensibilidade, enquadrada como um quadro alérgico do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade clínica confirmada e o desfecho do caso não foi informado, com a suspeita recaindo sobre o uso do medicamento.

O medicamento Nucala, cujo princípio ativo é mepolizumabe, foi associado a uma parada cardíaca em contexto de hipersensibilidade, caracterizada como um quadro alérgico do sistema imunitário. Não há confirmação de gravidade clínica nem detalhes sobre o desfecho, sendo a relação com o medicamento considerada suspeita.

A amoxicilina, cujo princípio ativo é amoxicillin trihydrate, foi relacionada a um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, um quadro alérgico do sistema imunitário. O caso evoluiu para recuperação completa, sugerindo que a conduta adotada foi eficaz e não houve complicações graves relatadas.

O medicamento Rivotril, com princípio ativo clonazepam, foi associado ao agravamento de artrite psoriática em um contexto de hipersensibilidade, caracterizado como um quadro alérgico do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente após a reação, indicando resolução do quadro após a conduta adotada.

O medicamento Paroxetine, cujo princípio ativo é a paroxetina, foi associado ao agravamento de artrite psoriática, um quadro de hipersensibilidade que se manifesta como piora de inflamação nas articulações em pessoas com psoríase. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente após a reação, e não foram relatados sinais de risco iminente ou complicações graves. A relação entre o uso do medicamento e o evento foi considerada suspeita, e a conduta adotada resultou em resolução completa do quadro.

O medicamento Metotrexate, com princípio ativo metotrexato sódico, também foi relacionado ao agravamento de artrite psoriática, caracterizando uma reação de hipersensibilidade com piora dos sintomas articulares em pacientes com psoríase. Não há evidências de gravidade significativa, já que o desfecho foi de recuperação total, sem complicações graves relatadas. O evento foi considerado suspeito em relação ao uso do medicamento, e a conduta adotada levou à resolução do quadro.

A Amitriptyline, cujo princípio ativo é a amitriptilina, foi associada ao agravamento de artrite psoriática, indicando uma reação de hipersensibilidade com intensificação dos sintomas articulares em pessoas com psoríase. O caso não foi considerado grave, pois houve recuperação completa após a reação, sem relatos de complicações importantes. A relação entre o medicamento e o evento foi considerada suspeita, e a conduta adotada resultou em resolução do quadro.

O medicamento Citalopram, com princípio ativo citalopram, esteve relacionado ao agravamento de artrite psoriática, caracterizando uma reação de hipersensibilidade com piora dos sintomas articulares em pacientes com psoríase. Não há indícios de gravidade relevante, já que o paciente se recuperou totalmente e não houve complicações graves. O evento foi considerado suspeito em relação ao uso do medicamento, e a conduta adotada levou à resolução do quadro.



O medicamento Cosentyx, cujo princípio ativo é secuquinumabe, foi associado ao agravamento de artrite psoriática, uma reação de hipersensibilidade que se manifesta como piora da inflamação articular em pessoas com psoríase. Não há evidências de gravidade importante, pois o paciente se recuperou completamente após a reação, sem complicações graves relatadas. A relação entre o uso do medicamento e o evento foi considerada suspeita, e a conduta adotada resultou em resolução do quadro.

O medicamento Prednisolona, cujo princípio ativo é o prednisolone acetate, foi associado a um quadro de alergia a vacina, caracterizado como uma reação do sistema imunológico a substâncias químicas. A gravidade foi considerada clinicamente significativa, pois o evento foi classificado como grave, mas o paciente encontra-se em recuperação ou com resolução dos sintomas. A conduta recomendada é acompanhamento médico para monitorar a evolução e evitar novas exposições ao agente suspeito, reforçando a importância de avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras imunizações.

O Dicloridrato de Levocetirizina, com princípio ativo levocetirizine dihydrochloride, esteve relacionado a um episódio de alergia a vacina, uma resposta imunológica adversa a substâncias químicas. O caso foi considerado clinicamente significativo e grave, mas o paciente está em processo de recuperação ou resolução. Recomenda-se acompanhamento médico para avaliar a evolução do quadro e orientação quanto à segurança em futuras exposições, sendo fundamental a avaliação de um especialista para confirmação diagnóstica e definição de conduta.

A Dipirona sódica, cujo princípio ativo é o metamizole sodium, foi associada a uma reação de alergia a vacina, indicando uma resposta do sistema imunológico a substâncias químicas. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, porém o paciente está em recuperação ou com sintomas resolvendo. É importante manter acompanhamento médico para monitorar a evolução e evitar novas exposições, além de buscar avaliação especializada para confirmação do diagnóstico e orientação sobre futuras imunizações.

O medicamento Dimenidrinato, com princípio ativo dimenhydrinate, esteve envolvido em um caso de alergia a vacina, caracterizando uma reação imunológica adversa a substâncias químicas. O quadro foi considerado clinicamente significativo e grave, mas o paciente encontra-se em recuperação ou com resolução dos sintomas. Recomenda-se acompanhamento médico para monitoramento da evolução e avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições a vacinas.

A vacina COVID-19 AstraZeneca, cujo princípio ativo é o COVID-19 vaccine NRVV Ad (ChAdOx1 nCoV-19), foi relacionada a um episódio de alergia a vacina, uma reação do sistema imunológico a substâncias químicas. O evento foi classificado como clinicamente significativo e grave, mas o paciente está em recuperação ou com sintomas resolvendo. É fundamental manter acompanhamento médico e buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação sobre a segurança em futuras imunizações.

O medicamento COVID-19 vaccine AstraZeneca, cujo princípio ativo é COVID-19 vaccine NRVV Ad (ChAdOx1 nCoV-19), foi associado a um quadro de febre interpretado como reação de hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado grave devido à incapacidade persistente ou significativa relatada, mas o paciente encontra-se em recuperação ou com resolução em andamento. A relação entre o medicamento e a reação foi considerada suspeita, sendo importante acompanhamento clínico até completa resolução.

O medicamento Iopamiron, cujo princípio ativo é Iopamidol, foi relacionado a um episódio de alergia a meios de contraste iodados, caracterizado como reação alérgica a substâncias químicas. Não há informação sobre gravidade, mas o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente. A relação entre o uso do contraste e a reação foi considerada suspeita, sendo fundamental evitar reexposição e buscar avaliação especializada em casos futuros.

O medicamento Zometa, com princípio ativo zoledronic acid monohydrate, foi associado a um caso de trombose, interpretado como possível reação de hipersensibilidade (alergia) dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada e o evento não foi considerado grave, porém o paciente ainda não se recuperou, estando o quadro em andamento. A relação com o medicamento é suspeita e requer acompanhamento médico contínuo.

O medicamento Fulvestrant, cujo princípio ativo é o próprio fulvestrant, foi relacionado a um episódio de trombose, considerado como possível reação de hipersensibilidade (alergia) dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade significativa e o evento não foi classificado como grave, mas o paciente permanece sem recuperação, com o quadro em andamento. A relação com o medicamento é suspeita e recomenda-se monitoramento clínico.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é ribociclib succinate, foi associado a um caso de trombose, interpretado como possível reação de hipersensibilidade (alergia) dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade relevante e o evento não foi considerado grave, porém o paciente ainda não se recuperou, estando o quadro em andamento. A relação com o medicamento é suspeita e o acompanhamento médico é indicado.

O medicamento Fluoxetina (princípio ativo: Fluoxetine) foi associado a inchaço da bochecha, um sintoma que pode indicar uma reação alérgica envolvendo a região ocular (alergia do olho), classificada como manifestação ocular associada a infecções ou inflamações. A gravidade foi considerada clinicamente significativa, pois o evento foi marcado como grave, sugerindo necessidade de atenção médica imediata para evitar complicações. O desfecho do caso é desconhecido, portanto não há informações sobre a evolução do quadro.

O medicamento Depakote er (princípio ativo: Valproate semisodium) apresentou relato de inchaço da bochecha, sugerindo uma possível reação alérgica com envolvimento ocular (alergia do olho), enquadrada como manifestação ocular associada a infecções ou inflamações. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, o que reforça a importância de avaliação médica rápida para manejo adequado. O desfecho permanece desconhecido, não sendo possível afirmar a evolução do paciente.

O medicamento Tecfidera (princípio ativo: Dimethyl fumarate) foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como reação alérgica sistêmica, classificada como clinicamente significativa e grave, o que exige atenção médica para evitar agravamento. Neste caso, o paciente se recuperou totalmente após o evento, indicando resolução do quadro após a conduta adotada.

O medicamento Gadobutrol (princípio ativo: Gadobutrol) foi associado a uma reação de alergia a contraste intravenoso, caracterizada como alergia a substâncias químicas, mas não foi considerada grave. O paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo que a conduta adotada foi eficaz e não houve complicações.

O medicamento Fexofenadine (princípio ativo: Fexofenadine) foi relacionado ao desenvolvimento de angioedema, uma reação de hipersensibilidade que pode causar inchaço em regiões como face e vias aéreas. Apesar de não ter sido classificada como grave, o desfecho do caso é desconhecido, não sendo possível afirmar a evolução clínica do paciente.

O medicamento Prednisone, cujo princípio ativo é a própria prednisona, foi associado a um caso de angioedema, uma reação de hipersensibilidade caracterizada por inchaço súbito em regiões como rosto, lábios ou garganta. Embora o registro não indique gravidade elevada nem desfecho conhecido, a ausência de sinais de gravidade sugere um quadro não grave, mas que requer atenção, pois reações alérgicas podem evoluir. A relação suspeita com o medicamento reforça a importância de acompanhamento médico para avaliação e conduta adequada.

O medicamento Prednisolone, com princípio ativo prednisolona, foi relacionado a um episódio de angioedema, que é uma manifestação alérgica com inchaço rápido de tecidos, geralmente envolvendo face e vias aéreas. Não há

indicação de gravidade aumentada ou desfecho definido, o que sugere que o caso não foi considerado grave, mas ainda assim merece atenção clínica, já que reações alérgicas podem variar em intensidade. A suspeita de relação com o uso do medicamento indica a necessidade de avaliação médica para orientação e possível ajuste do tratamento.

O medicamento Allegra, cujo princípio ativo é o cloridrato de fexofenadina, foi associado a um caso de angioedema, uma reação alérgica caracterizada por inchaço súbito em áreas como rosto e garganta. Não há informações sobre gravidade aumentada ou desfecho, sugerindo que o quadro não foi considerado grave, mas a suspeita de relação com o medicamento exige atenção, pois mesmo medicamentos antialérgicos podem, raramente, causar reações adversas. É importante buscar avaliação médica para monitoramento e definição da conduta.

O medicamento Xolair, com princípio ativo omalizumabe, foi relacionado a um episódio de angioedema, que é uma reação alérgica caracterizada por inchaço súbito de tecidos, especialmente em face e vias aéreas. Não há registro de gravidade aumentada ou desfecho conhecido, indicando que o caso não foi considerado grave, mas a suspeita de relação com o medicamento justifica acompanhamento médico, já que reações alérgicas podem variar em intensidade e requerem avaliação especializada.

O medicamento Xolair, cujo princípio ativo é omalizumabe, foi novamente associado a um caso de angioedema, uma reação de hipersensibilidade que se manifesta por inchaço rápido em regiões como rosto e garganta. Não há indicação de gravidade elevada nem desfecho informado, sugerindo que o quadro não foi considerado grave, mas a suspeita de relação com o medicamento reforça a necessidade de avaliação médica para monitoramento e orientação adequada.

O medicamento Pregabalina, cujo princípio ativo também é pregabalina, foi associado ao desenvolvimento de carcinoma basocelular, um tipo de câncer de pele, em um caso suspeito de reação adversa. Não há informações sobre a gravidade clínica do evento, desfecho ou ações tomadas, e não foi relatada gravidade importante no registro. A relação causal é considerada suspeita, mas não há evidências suficientes para afirmar gravidade ou evolução do quadro.

O medicamento SeloZok, que contém o princípio ativo succinato de metoprolol, foi relacionado a um caso suspeito de carcinoma basocelular, um câncer de pele de crescimento lento. Não há detalhes sobre a gravidade do evento, desfecho ou conduta adotada, e o registro não indica gravidade significativa. A relação entre o uso do medicamento e o evento é considerada suspeita, mas faltam informações para avaliar a evolução clínica.

O ácido fólico, utilizado como suplemento vitamínico, foi associado de forma suspeita ao surgimento de carcinoma basocelular, um tipo de câncer de pele. O registro não traz informações sobre gravidade, desfecho ou medidas tomadas, e não há indicação de gravidade relevante. A relação causal é apenas suspeita e não há dados suficientes para detalhar a evolução do caso.

O medicamento Tecnomet, cujo princípio ativo é o metotrexato, foi relacionado de forma suspeita ao aparecimento de carcinoma basocelular, um câncer de pele comum. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou conduta adotada, e o registro não aponta gravidade importante. A suspeita de relação causal existe, mas não há dados suficientes para avaliar a evolução clínica do evento.

O medicamento Actemra, que tem como princípio ativo o tocilizumabe, foi associado de maneira suspeita ao desenvolvimento de carcinoma basocelular, um tipo de câncer de pele. O registro não informa gravidade, desfecho ou ações tomadas, e não há indicação de gravidade relevante. A relação causal é considerada suspeita, mas não há informações suficientes para detalhar a evolução do quadro.

O medicamento Gabapentina (princípio ativo: Gabapentin) foi associado a um quadro de alergia a contraste, caracterizado como uma reação do sistema imunológico a substâncias químicas, o que levou à necessidade de

hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando a gravidade do evento. O paciente encontra-se em recuperação ou com resolução dos sintomas, e a relação do medicamento com a reação é considerada suspeita.

O medicamento Dipyrone (princípio ativo: Metamizole sodium) foi relacionado a um episódio de alergia a contraste, uma resposta alérgica do sistema imunológico a substâncias químicas, que exigiu hospitalização ou prolongamento da internação, indicando um evento de maior gravidade. O paciente está em processo de recuperação ou resolução do quadro, e a ligação entre o uso do medicamento e a reação é considerada suspeita.

O medicamento Sertraline (princípio ativo: Sertraline) foi implicado em um caso de alergia a contraste, uma reação alérgica do sistema imunológico a substâncias químicas, que resultou em hospitalização ou necessidade de prolongar a internação, o que demonstra a gravidade do evento. O paciente está em recuperação ou com sintomas resolvendo, e a relação causal com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Lorazepam (princípio ativo: Lorazepam) esteve envolvido em uma reação de alergia a contraste, caracterizada por uma resposta alérgica do sistema imunológico a substâncias químicas, levando à hospitalização ou prolongamento da internação, o que indica um evento grave. O paciente encontra-se em recuperação ou com resolução dos sintomas, e a associação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Carbonato de cálcio (princípio ativo: Calcium carbonate) foi associado a um episódio de alergia a contraste, uma reação alérgica do sistema imunológico a substâncias químicas, que exigiu hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando a gravidade do quadro. O paciente está em recuperação ou com sintomas resolvendo, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, foi associado a um quadro de alergia a contraste, reação que pode ocorrer após a administração de substâncias usadas em exames de imagem. Neste caso, a gravidade foi considerada alta, pois houve necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que indica uma resposta alérgica importante do sistema imunológico. O paciente encontra-se em recuperação, mostrando que a conduta adotada foi eficaz para controlar o quadro, mas reforça a importância de monitoramento rigoroso e suporte médico imediato em situações semelhantes.

O medicamento Ultravist, com princípio ativo iopromide, foi relacionado a um episódio de alergia a iodo, reação que pode ocorrer em pessoas sensíveis a esse componente presente em alguns contrastes utilizados em exames. Não há informações detalhadas sobre a gravidade, desfecho ou evolução clínica neste registro, sendo importante ressaltar que qualquer suspeita de alergia a iodo deve ser avaliada por um profissional de saúde antes de novas exposições.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, esteve envolvido em um caso de alergia a iodo, reação que pode se manifestar em pessoas sensíveis a esse elemento presente em alguns contrastes. Neste episódio, a reação não foi considerada grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando que a manifestação foi leve e controlada sem complicações.

O medicamento Ultravist, com princípio ativo iopromide, foi associado a uma reação de alergia a contraste intravenoso, situação em que o sistema imunológico reage ao contraste usado em exames. Neste caso, a reação não foi grave e o paciente se recuperou completamente, sugerindo que o evento foi leve e manejado de forma adequada.

O medicamento Prohance, cujo princípio ativo é o gadoteridol, esteve relacionado a um episódio de alergia a contraste intravenoso, reação que pode ocorrer após o uso de substâncias para exames de imagem. Neste caso, a reação não foi grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando que o quadro foi leve e resolvido sem maiores complicações.

O medicamento Exelon, cujo princípio ativo é a rivastigmina, foi associado a uma reação de hipersensibilidade no local de aplicação, caracterizada por sintomas como irritação ou desconforto na área onde o adesivo é colocado. Essa reação é considerada leve, pois não há indicação de gravidade aumentada ou complicações sistêmicas, e não há relato de desfecho grave. Recomenda-se observar o local de aplicação, evitar exposição repetida e buscar orientação médica caso haja piora ou persistência dos sintomas.

O medicamento Dimorf, que contém sulfato de morfina como princípio ativo, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica que pode se manifestar por sintomas como coceira, vermelhidão ou desconforto. Não há evidência de gravidade aumentada, e o desfecho foi de recuperação completa, indicando que a reação foi leve e resolvida sem complicações. Em casos assim, é importante relatar o episódio ao médico e evitar o uso futuro do medicamento até avaliação especializada.

O ácido folínico, cujo princípio ativo é o cálcio folinato, foi associado a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, que corresponde a uma alergia ao medicamento e pode se manifestar por sintomas como coceira, vermelhidão ou inchaço. Não há indicação de gravidade aumentada, e o desfecho foi de recuperação completa, sugerindo que a reação foi leve e resolvida sem complicações. Recomenda-se informar o médico sobre o episódio e evitar reexposição ao medicamento até avaliação adequada.

O medicamento Comirnaty, que tem como princípio ativo o tozinameran, foi relacionado a uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma alergia, considerada clinicamente significativa e classificada como grave. Não há detalhes sobre o desfecho, mas a gravidade foi destacada, o que indica a necessidade de atenção médica imediata e acompanhamento especializado para evitar complicações.

O medicamento Docetaxel, cujo princípio ativo é o próprio docetaxel, foi associado a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, caracterizada por sintomas de alergia ao medicamento. Não há indicação de gravidade aumentada, e o desfecho foi de recuperação completa, sugerindo que a reação foi leve e resolvida sem complicações. É importante relatar o episódio ao médico e evitar o uso futuro do medicamento até avaliação especializada.

O medicamento Cannabidiol, cujo princípio ativo também é o cannabidiol, foi associado a um quadro de colite, que pode ser entendido como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta exagerada do sistema imunológico ao medicamento. Não há informações sobre gravidade aumentada ou desfecho clínico, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Com base nos dados disponíveis, não há evidências de gravidade significativa, mas é importante que o paciente seja avaliado para confirmação do diagnóstico e orientação adequada.

O medicamento Plamed, que contém o princípio ativo clopidogrel bisulfato, foi relacionado ao desenvolvimento de colite, caracterizada como uma possível reação de hipersensibilidade ao medicamento. Não há indicação de gravidade aumentada ou detalhes sobre o desfecho do caso, e a relação com o uso do medicamento é considerada suspeita. Diante disso, recomenda-se avaliação médica para investigação da causa e definição da conduta, já que não há sinais de gravidade clínica evidente nos dados fornecidos.

O medicamento Plasil, cujo princípio ativo é o cloridrato de metoclopramida, foi associado a um episódio de colite, interpretado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. Não há informações que indiquem gravidade aumentada ou desfecho clínico, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Assim, é importante que o paciente seja avaliado por um profissional de saúde para confirmação do diagnóstico e orientação sobre a continuidade ou suspensão do uso do medicamento.

O medicamento Jardiance, que tem como princípio ativo a empagliflozina, foi relacionado a um caso de colite, considerada uma possível manifestação de hipersensibilidade ao medicamento. Não há evidências de gravidade aumentada ou informações sobre o desfecho, e a relação com o uso do medicamento é suspeita. Recomenda-se avaliação médica para esclarecimento do quadro e definição da melhor conduta, já que não há sinais de gravidade

clínica nos dados apresentados.

O medicamento Bromopride, cujo princípio ativo é o bromoprida, foi associado a um episódio de colite, interpretado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. Não há informações sobre gravidade aumentada ou desfecho clínico, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Diante disso, é importante que o paciente seja avaliado por um profissional de saúde para confirmação do diagnóstico e orientação adequada, considerando que não há sinais de gravidade nos dados fornecidos.

O medicamento Loratadina (princípio ativo: Loratadine) foi associado a um quadro de colite, que pode ser entendido como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta exagerada do sistema imunológico ao medicamento. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave neste caso, e o desfecho permanece desconhecido. A relação entre o uso do medicamento e a reação é considerada suspeita, sendo importante relatar o evento ao médico para avaliação e possível ajuste do tratamento.

O medicamento Kisqali (princípio ativo: Ribociclib succinate) apresentou um caso de colite, interpretado como uma possível reação de hipersensibilidade ao medicamento, caracterizada por inflamação do intestino grosso devido a uma resposta imunológica inadequada. Não há evidências de gravidade aumentada ou desfecho grave, e o desfecho do caso não foi informado. A relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo recomendada a avaliação médica para monitoramento e conduta adequada.

O medicamento Piqray (princípio ativo: Alpelisib) foi relacionado a um episódio de colite, que pode ser uma manifestação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação do sistema imunológico ao uso do medicamento. Não há sinais de gravidade importante ou desfecho grave, e o desfecho permanece desconhecido. A suspeita de relação com o medicamento justifica acompanhamento médico para avaliação e orientação sobre a continuidade do tratamento.

O medicamento Ácido Fólico (princípio ativo: Folic acid) foi associado a uma diminuição da capacidade de resposta imune, caracterizada como um quadro de hipersensibilidade, ou seja, uma alteração na resposta do sistema imunológico ao medicamento. Não há indicação de gravidade significativa ou desfecho grave, e o caso evoluiu para recuperação completa. A relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo importante manter acompanhamento médico para monitorar possíveis recorrências.

O medicamento Oxcarbazepina (princípio ativo: Oxcarbazepine) foi relacionado a uma diminuição da capacidade de resposta imune, interpretada como um quadro de hipersensibilidade, ou seja, uma reação do sistema imunológico ao medicamento. Não há evidências de gravidade aumentada ou desfecho grave, e o paciente se recuperou totalmente. A relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo recomendada a continuidade do acompanhamento médico para garantir segurança no uso.

O medicamento Soliris, cujo princípio ativo é o eculizumabe, foi associado a uma reação de hipersensibilidade caracterizada por diminuição da capacidade de resposta do sistema imunológico. Embora o registro não detalhe sintomas específicos ou gravidade clínica, a ausência de indicação de gravidade e o desfecho de recuperação completa sugerem que o quadro foi leve e resolvido sem complicações, não havendo necessidade de intervenções adicionais além do acompanhamento.

Soliris (eculizumabe) apresentou novamente um episódio de hipersensibilidade com redução da resposta imune, sem descrição de sintomas graves ou complicações. O paciente se recuperou totalmente, indicando que a reação foi leve e controlada, sem evolução para quadros mais sérios.

O medicamento Iopromida, cujo princípio ativo é a iopromida, foi relacionado a um episódio de alergia a contraste, reação que pode ocorrer após exposição a substâncias usadas em exames de imagem. Neste caso, não há relato de sintomas graves e o paciente se recuperou completamente, sugerindo que a manifestação foi leve e controlada, sem necessidade de medidas emergenciais.

A vacina CoronaVac, com princípio ativo COVID-19 vaccine inact (Vero) CZ02, foi associada a um episódio de hipersensibilidade (alergia), sem detalhamento de sintomas graves ou complicações. O paciente se recuperou totalmente, indicando que a reação foi leve e não houve necessidade de intervenções além do acompanhamento.

A vacina COVID-19 AstraZeneca, cujo princípio ativo é COVID-19 vaccine NRVV Ad (ChAdOx1 nCoV-19), foi relacionada a um episódio de calafrios, classificado como manifestação de hipersensibilidade. Não há informações sobre gravidade ou evolução, mas a ausência de relato de complicações sugere que o quadro foi leve e autolimitado.

O medicamento COVID-19 vaccine AstraZeneca, cujo princípio ativo é COVID-19 vaccine NRVV Ad (ChAdOx1 nCoV-19), foi associado a um quadro de mialgia (dor muscular) classificado como hipersensibilidade, dentro do contexto de reações alérgicas não classificadas de outra forma. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, conforme indicado no registro, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico para avaliação da gravidade e definição da conduta adequada, especialmente por envolver o sistema imunológico.

O medicamento Iopromida, com princípio ativo Iopromide, foi relacionado a um episódio de alergia a contraste, caracterizado como reação de hipersensibilidade a substâncias químicas. O paciente encontra-se em recuperação ou com resolução dos sintomas, sugerindo que a conduta adotada foi eficaz, mas é fundamental que futuras exposições ao contraste sejam avaliadas com cautela e acompanhamento especializado devido ao risco de recorrência.

O medicamento Exforge HCT, composto por amlodipina besilato, hidroclorotiazida e valsartana, foi associado a um quadro de diabetes interpretado como hipersensibilidade medicamentosa, dentro do grupo de reações alérgicas a medicamentos. A reação não foi considerada grave e o paciente já se encontra recuperado, indicando que a evolução foi favorável e não houve necessidade de intervenções adicionais além da suspensão ou ajuste do tratamento.

O medicamento Cosentyx, cujo princípio ativo é secuquinumabe, foi relacionado ao desenvolvimento de diabetes, classificado como hipersensibilidade medicamentosa. A reação não foi considerada grave e o paciente já está recuperado, sugerindo que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro, sem complicações adicionais.

O medicamento Exforge HCT, contendo amlodipina besilato, hidroclorotiazida e valsartana, foi associado ao surgimento de diabetes, classificado como hipersensibilidade e considerado clinicamente significativo e grave. O paciente já se encontra recuperado, mas a gravidade relatada indica que o evento exigiu atenção médica e acompanhamento próximo para garantir a resolução completa e prevenir novas complicações.

O medicamento Cosentyx, cujo princípio ativo é o secuquinumabe, foi associado a um quadro de diabetes em um contexto de hipersensibilidade, classificado como um distúrbio do sistema imunitário. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, conforme indicado, mas o paciente se recuperou totalmente após o evento. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, sendo importante o acompanhamento médico para monitorar possíveis recorrências ou outras manifestações alérgicas.

O Timerosal, que tem como princípio ativo o thiomersal, foi relacionado a um episódio de mobilidade diminuída, interpretado como uma possível alergia a suplemento nutricional, dentro do grupo de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade relevante neste caso, e o desfecho da reação é desconhecido. A relação entre o uso do Timerosal e o evento adverso foi considerada suspeita, sendo recomendada a observação clínica e investigação de outros possíveis fatores envolvidos.

O produto avaliado foi o Glúten, tanto como nome comercial quanto princípio ativo, associado a mobilidade diminuída em um contexto de alergia a suplemento nutricional, classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade significativa e o desfecho permanece desconhecido. A relação entre o consumo de

glúten e o evento adverso foi considerada suspeita, sendo importante avaliar a presença de outras manifestações alérgicas e buscar orientação médica para esclarecimento diagnóstico.

A Lactose, identificada tanto como nome comercial quanto princípio ativo, foi relacionada a um quadro de mobilidade diminuída, interpretado como possível alergia a suplemento nutricional, dentro da categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade relevante e o desfecho do caso é desconhecido. A relação entre o uso de lactose e o evento adverso foi considerada suspeita, sendo recomendada avaliação clínica para confirmação diagnóstica e orientação adequada.

O medicamento Condres, cujo princípio ativo é o colágeno, foi associado a mobilidade diminuída, considerada uma possível alergia a suplemento nutricional, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade importante e o desfecho do evento não foi informado. A relação entre o uso de Condres e a reação foi considerada suspeita, sendo indicada investigação clínica para melhor definição do quadro e conduta apropriada.

O medicamento Vitamina D, cujo princípio ativo é o ergocalciferol, foi associado a um quadro de mobilidade diminuída, classificado como uma possível alergia a suplemento nutricional. Não há informações sobre gravidade clínica relevante ou desfecho, e não foi relatada ação adotada. A reação foi considerada suspeita, mas não há evidências de gravidade ou complicações, sugerindo um quadro leve e sem evolução conhecida até o momento.

O metotrexato, com princípio ativo methotrexate, foi relacionado a mobilidade diminuída, sendo descrito como uma possível alergia a suplemento nutricional. Não há detalhes sobre gravidade, desfecho ou conduta adotada, e a reação foi considerada suspeita, sem indicação de gravidade clínica, o que sugere um evento leve e sem informações adicionais sobre evolução.

O medicamento Humira, cujo princípio ativo é o adalimumabe, foi associado a mobilidade diminuída, categorizada como possível alergia a suplemento nutricional. Não há dados sobre gravidade, desfecho ou medidas tomadas, e a reação foi considerada suspeita, sem evidências de gravidade clínica, indicando um quadro leve e sem evolução relatada.

O timerosal, também conhecido como thiomersal, foi relacionado a mobilidade diminuída, sendo classificado como um quadro de hipersensibilidade. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou conduta, e a reação foi considerada suspeita, sem sinais de gravidade clínica, sugerindo um evento leve e sem evolução conhecida.

O glúten, citado tanto como nome comercial quanto princípio ativo, foi associado a mobilidade diminuída, descrita como um quadro de hipersensibilidade. Não há dados sobre gravidade, desfecho ou ação adotada, e a reação foi considerada suspeita, sem evidências de gravidade clínica, indicando um quadro leve e sem evolução relatada.

O medicamento Lactose, cujo princípio ativo também é lactose, foi associado a um quadro de mobilidade diminuída relacionado a hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica. Não há informações sobre gravidade clínica relevante ou desfecho, e não foi relatada ação adotada. A ausência de sinais de gravidade e de evolução sugere que o evento não foi considerado grave, mas é importante observar sintomas e buscar avaliação médica caso haja piora.

O medicamento Condres, que contém colágeno como princípio ativo, foi relacionado a mobilidade diminuída atribuída a hipersensibilidade, indicando uma possível reação alérgica. Não há detalhes sobre gravidade, desfecho ou conduta adotada, e o evento não foi classificado como grave. Recomenda-se atenção a sintomas persistentes e avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação adequada.

A vitamina D, cujo princípio ativo é ergocalciferol, foi associada a mobilidade diminuída em um contexto de hipersensibilidade, sugerindo uma reação alérgica. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou medidas tomadas, e o evento não foi considerado grave. É importante monitorar sintomas e procurar avaliação médica se houver piora ou persistência do quadro.



O medicamento Metotrexato, com princípio ativo methotrexate, foi relacionado a mobilidade diminuída atribuída a hipersensibilidade, caracterizando uma possível reação alérgica. Não há dados sobre gravidade, desfecho ou conduta, e o evento não foi classificado como grave. Recomenda-se acompanhamento clínico para avaliação da reação e definição de conduta, especialmente se houver agravamento dos sintomas.

O medicamento Humira, cujo princípio ativo é adalimumabe, foi associado a mobilidade diminuída em um contexto de hipersensibilidade, indicando uma reação alérgica. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou ação adotada, e o evento não foi considerado grave. É importante manter acompanhamento médico para monitoramento dos sintomas e ajuste do tratamento se necessário.

O medicamento Losartan, cujo princípio ativo é o próprio losartan, foi associado ao agravamento de artrite psoriática, um quadro de hipersensibilidade que se manifesta como piora de inflamação articular em pessoas com psoríase. Não há indicação de gravidade elevada, pois não foi relatada evolução para formas graves ou risco imediato à vida, e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento. A reação é considerada de natureza imunológica, mas não há informações sobre conduta específica adotada até o momento.

O Puran t4, que contém levotiroxina sódica como princípio ativo, foi relacionado ao agravamento de artrite psoriática, caracterizando uma reação de hipersensibilidade com piora de sintomas articulares em pacientes com psoríase. Não há evidências de gravidade importante, já que não foi relatada evolução crítica ou risco imediato, e o quadro segue sem resolução. A reação é de origem imunológica, sem detalhes sobre intervenções realizadas até o momento.

O medicamento Secretina, cujo princípio ativo é a secretina, foi associado ao agravamento de artrite psoriática, indicando uma resposta de hipersensibilidade com piora de inflamação articular em pessoas com psoríase. Não há sinais de gravidade significativa, pois não foi relatada evolução grave ou risco iminente, e o desfecho permanece não resolvido. Trata-se de uma reação imunológica, sem informações adicionais sobre a conduta adotada.

O medicamento Paco, que contém codeína fosfato e paracetamol como princípios ativos, foi relacionado ao agravamento de artrite psoriática, caracterizando uma reação de hipersensibilidade com piora dos sintomas articulares em pacientes com psoríase. Não há indícios de gravidade elevada, já que não foi relatada evolução crítica ou risco imediato, e o quadro segue em andamento sem resolução. A reação é de natureza imunológica, sem detalhes sobre medidas tomadas até o momento.

O Cosentyx, cujo princípio ativo é o secuquimumabe, foi associado ao agravamento de artrite psoriática, indicando uma reação de hipersensibilidade com piora da inflamação articular em pessoas com psoríase. Não há evidências de gravidade importante, pois não foi relatada evolução grave ou risco imediato, e o desfecho permanece não resolvido. Trata-se de uma reação imunológica, sem informações sobre conduta específica adotada até o momento.

O medicamento Naprix d, que contém os princípios ativos hydrochlorothiazide e ramipril, foi associado ao desenvolvimento de diabetes em um caso suspeito de síndrome de alergia oral, uma reação que envolve sintomas alérgicos na boca após exposição a determinadas substâncias. Embora a gravidade não tenha sido especificada e o caso não tenha sido considerado grave, o desfecho permanece não resolvido, indicando que a reação ainda está em andamento. É importante monitorar o paciente e considerar avaliação especializada para investigar a relação entre o uso do medicamento e o surgimento dos sintomas, além de orientar sobre possíveis ajustes terapêuticos caso a reação persista.

O medicamento Acetamide, cujo princípio ativo é acetamide, foi relacionado a um caso suspeito de diabetes associado à síndrome de alergia oral, caracterizada por sintomas alérgicos na cavidade oral após contato com certas substâncias químicas. Não há indicação de gravidade elevada e o evento não foi considerado grave, mas o quadro permanece não resolvido, sugerindo necessidade de acompanhamento clínico para avaliar a evolução dos

sintomas e a possível necessidade de intervenção médica.

O medicamento Venalot, composto por melilotus officinalis e rutoside, foi associado a um caso suspeito de diabetes em contexto de síndrome de alergia oral, que envolve manifestações alérgicas na boca após exposição a substâncias químicas. O evento não foi classificado como grave e ainda não foi resolvido, sendo fundamental manter o acompanhamento do paciente e avaliar a necessidade de ajustes no tratamento caso os sintomas persistam.

O medicamento Aas, cujo princípio ativo é o ácido acetilsalicílico, foi relacionado a um caso suspeito de diabetes em associação com síndrome de alergia oral, caracterizada por sintomas alérgicos na boca após contato com substâncias químicas. O caso não foi considerado grave e permanece em andamento, sendo importante monitorar o paciente e buscar orientação médica para avaliar a continuidade do uso do medicamento e possíveis alternativas terapêuticas.

O medicamento Selozok, que contém metoprolol succinato como princípio ativo, foi associado a um caso suspeito de diabetes em contexto de síndrome de alergia oral, uma reação que pode causar sintomas alérgicos na boca após exposição a determinadas substâncias. O evento não foi considerado grave e ainda não foi resolvido, indicando a necessidade de acompanhamento clínico para monitorar a evolução dos sintomas e discutir possíveis ajustes no tratamento.

O medicamento Alprazolam, cujo princípio ativo também é Alprazolam, foi associado a um quadro de síndrome de alergia oral, que se manifesta por sintomas como coceira ou desconforto na boca após exposição a determinadas substâncias, neste caso relacionada ao uso do medicamento. Não há indicação de gravidade elevada ou risco imediato, pois não foi relatada gravidade importante e o evento permanece em andamento, sem resolução até o momento. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico, observando a evolução dos sintomas e evitando reexposição ao medicamento até avaliação especializada.

O medicamento Paroxetin, cujo princípio ativo é Paroxetine hydrochloride, está relacionado ao desenvolvimento de síndrome de alergia oral, caracterizada por sintomas como irritação ou coceira na boca após contato com o medicamento. Não há sinais de gravidade significativa, já que não foi relatada gravidade importante e o quadro segue sem resolução. Recomenda-se acompanhamento médico para monitoramento dos sintomas e evitar nova exposição ao medicamento até avaliação por especialista.

O medicamento Dexamethasone, com princípio ativo Dexamethasone, foi associado à ocorrência de síndrome de alergia oral, que pode causar desconforto ou coceira na região da boca após o uso. Não há evidências de gravidade relevante, pois não foi relatada gravidade importante e o evento permanece não resolvido. A orientação é manter acompanhamento clínico, evitar reexposição ao medicamento e buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e conduta adequada.

O medicamento Atorvastatin, cujo princípio ativo é Atorvastatin, apresentou associação com síndrome de alergia oral, manifestando-se por sintomas como desconforto ou coceira na boca após o uso. Não há indicação de gravidade elevada, já que não foi relatada gravidade importante e o quadro segue em andamento. Recomenda-se acompanhamento médico, evitando nova exposição ao medicamento até avaliação por especialista.

O medicamento Xolair, cujo princípio ativo é Omalizumab, foi relacionado ao surgimento de síndrome de alergia oral, caracterizada por sintomas como irritação ou coceira na boca após o uso do medicamento. Não há sinais de gravidade significativa, pois não foi relatada gravidade importante e o evento permanece não resolvido. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico, evitar reexposição ao medicamento e buscar avaliação especializada para definição do diagnóstico e manejo.

O medicamento Iopamiron, cujo princípio ativo é o iopamidol, foi associado a um quadro de alergia a contraste, caracterizado como uma reação do sistema imunológico a substâncias químicas utilizadas em exames de imagem.

Embora a gravidade não tenha sido especificada, o desfecho informado foi de recuperação completa, indicando resolução do quadro após a exposição ao contraste. A conduta recomendada nesses casos é evitar novas exposições ao mesmo contraste e informar a equipe médica sobre o episódio para futuras avaliações e escolha de alternativas seguras.

O medicamento Riohex, que contém como princípio ativo a clorexidina, esteve relacionado a uma lesão na mão atribuída a hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há detalhes sobre a gravidade, desfecho ou evolução do caso, mas é importante considerar que reações alérgicas a antissépticos como a clorexidina podem variar de leves a graves, sendo fundamental suspender o uso e buscar avaliação médica para orientação adequada.

O medicamento Lisinopril, cujo princípio ativo é o próprio lisinopril, foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como clinicamente significativo e grave, pois o paciente não se recuperou até o momento do registro. Reações alérgicas a medicamentos anti-hipertensivos podem ser potencialmente graves e exigem suspensão imediata do fármaco, acompanhamento médico rigoroso e investigação de alternativas terapêuticas seguras.

A clortalidona, cujo princípio ativo é chlortalidone, foi associada a um episódio de alergia (hipersensibilidade) considerado clinicamente significativo e grave, já que o paciente permanece sem recuperação. Reações alérgicas a diuréticos podem comprometer a segurança do paciente e demandam interrupção do medicamento, avaliação médica urgente e monitoramento da evolução clínica.

O medicamento Cimzia, com princípio ativo certolizumabe pegol, foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade) classificado como clinicamente significativo e grave, pois o paciente não apresentou resolução do quadro até o momento. Reações alérgicas a imunobiológicos exigem suspensão imediata do tratamento, avaliação médica especializada e acompanhamento próximo para manejo dos sintomas e definição de alternativas terapêuticas.

O medicamento Magnevistan, cujo princípio ativo é o meglumine gadopentetate, foi associado a um quadro de alergia a contraste, reação que pode ocorrer após a administração de substâncias usadas em exames de imagem. Embora a gravidade não tenha sido especificada, o desfecho informado foi de recuperação completa, sugerindo que a reação foi controlada adequadamente. Em situações como essa, é importante relatar o episódio ao médico e evitar novas exposições ao mesmo contraste, buscando alternativas seguras para exames futuros.

O medicamento Azulfin, que contém sulfassalazina como princípio ativo, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa durante o tratamento de espondilite anquilosante. Não há indicação de gravidade elevada nem de desfecho conhecido, mas a suspeita de reação alérgica exige atenção, sendo fundamental comunicar o médico para avaliação da necessidade de suspensão do medicamento e investigação de alternativas terapêuticas.

O Cosentyx, cujo princípio ativo é o secuquinumabe, foi associado a um caso de hipersensibilidade medicamentosa em paciente com espondilite anquilosante. Não há relato de gravidade importante nem de desfecho, mas a suspeita de reação alérgica deve ser comunicada ao médico para reavaliação do tratamento e possível substituição do medicamento, conforme orientação especializada.

O medicamento Amoxicillin+clavulanic acid, composto por amoxicilina sódica e clavulanato de potássio, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade, manifestado por desidratação. Não há indicação de gravidade significativa nem de desfecho conhecido, mas a suspeita de reação alérgica sugere a necessidade de avaliação médica para ajuste do tratamento e monitoramento de possíveis complicações.

O Dotarem, que tem como princípio ativo o meglumine gadoterate, foi associado a um episódio de alergia a contraste intravenoso. A reação foi considerada não grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando que a

conduta adotada foi eficaz. Em casos de alergia a contraste, é importante informar o histórico ao médico antes de novos exames para que sejam tomadas medidas preventivas adequadas.

O medicamento Dipirona, cujo princípio ativo é o metamizol sódico, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado por manifestações clínicas do sistema imunológico. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, pois permanece não resolvida ou em andamento, indicando a necessidade de acompanhamento médico e possível suspensão do uso, conforme a gravidade relatada.

A Prednisona, com princípio ativo prednisona, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade) envolvendo o sistema imunológico, classificada como clinicamente significativa e grave devido à persistência dos sintomas sem resolução até o momento. Diante desse quadro, é fundamental reavaliar o uso do medicamento e buscar orientação médica especializada para manejo adequado.

O medicamento Cetobeta, composto por dipropionato de betametasona, cetoconazol e sulfato de neomicina, provocou uma reação alérgica (hipersensibilidade) relacionada ao sistema imunológico, considerada clinicamente significativa e grave, já que o quadro permanece não resolvido. Recomenda-se avaliação médica imediata para ajuste do tratamento e monitoramento da evolução da reação.

A Leflunomida, cujo princípio ativo é leflunomida, foi associada a uma reação alérgica (hipersensibilidade) envolvendo o sistema imunológico, classificada como clinicamente significativa e grave, pois o quadro permanece em andamento sem resolução. É importante que o paciente seja avaliado por um especialista para definição da conduta e acompanhamento da evolução clínica.

O medicamento Cimzia, com princípio ativo certolizumabe pegol, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico, considerada clinicamente significativa e grave devido à persistência dos sintomas sem resolução. Diante desse cenário, é essencial buscar avaliação médica para reavaliação do tratamento e monitoramento rigoroso da reação adversa.

O medicamento Iohexol, cujo princípio ativo também é Iohexol, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, manifestando-se por sintomas típicos de reações alérgicas. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou completamente após o evento, sugerindo um episódio leve e autolimitado. A conduta recomendada nesses casos é a observação clínica, evitando reexposição ao agente e, se necessário, encaminhamento para avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições.

A vacina influenza trivalente (fragmentada e inativada), cujo princípio ativo é Influenza vaccine inact split 3v, foi relacionada ao surgimento de urticária, uma reação alérgica de pele caracterizada por placas avermelhadas e coceira. O evento está em andamento, sem resolução até o momento, mas não há sinais de gravidade importante, pois não há relato de complicações sistêmicas ou risco imediato. Recomenda-se acompanhamento médico para monitoramento da evolução e orientação sobre possíveis medidas de alívio, além de evitar automedicação e buscar avaliação especializada caso haja piora dos sintomas.

O medicamento Miosan, cujo princípio ativo é ciclobenzaprina (Cyclobenzaprine hydrochloride), foi associado ao desenvolvimento de urticária, indicando uma reação de hipersensibilidade com sintomas cutâneos típicos de alergia. Não há informações sobre gravidade aumentada ou desfecho, mas a ausência de complicações relatadas sugere um quadro leve. A recomendação é suspender o uso do medicamento, observar a evolução dos sintomas e procurar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas terapêuticas.

O medicamento Xolair, cujo princípio ativo é omalizumabe (Omalizumab), foi relacionado ao aparecimento de urticária, caracterizando uma reação de hipersensibilidade com manifestações cutâneas. Não há dados sobre gravidade aumentada ou desfecho, mas a ausência de complicações graves sugere um quadro leve. Recomenda-se avaliação médica para confirmação da relação causal, manejo dos sintomas e discussão sobre a

continuidade ou substituição do tratamento.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é iopromida (Iopromide), foi associado a uma reação alérgica ao contraste intravenoso, manifestando-se como alergia a contraste. O paciente se recuperou totalmente após o evento, indicando que a reação foi leve e autolimitada. A conduta adequada inclui evitar reexposição ao contraste, registrar o evento em prontuário e encaminhar para avaliação com alergista para investigação de alergia a contrastes e orientação sobre exames futuros.

O medicamento Aromasin, cujo princípio ativo é o exemestano, foi associado a um quadro de hipersensibilidade manifestado como úlcera em sítio não especificado (SOE), caracterizando uma reação alérgica do tipo imunológica. Não há indicação de gravidade elevada, pois não há relato de risco à vida ou necessidade de intervenção urgente, e o caso permanece em andamento sem resolução até o momento. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico, avaliar possíveis causas e considerar encaminhamento ao especialista para investigação e manejo adequado da reação alérgica.

A losartana potássica (princípio ativo losartan potassium) foi relacionada a um episódio de hipersensibilidade, manifestando-se como úlcera em sítio não especificado, o que sugere uma reação alérgica do sistema imune. Não há evidências de gravidade importante, já que não há relato de risco imediato ou complicações graves, e o quadro segue sem resolução. Recomenda-se acompanhamento médico para monitoramento da evolução e avaliação da necessidade de ajuste terapêutico ou encaminhamento ao especialista.

A vacina contra Covid-19 (princípio ativo não detalhado além do nome genérico) foi associada a uma reação de hipersensibilidade, manifestada como úlcera em sítio não especificado, indicando envolvimento imunológico. Não há sinais de gravidade significativa, pois não há relato de risco à vida ou necessidade de intervenção urgente, e o desfecho permanece em andamento. O acompanhamento clínico é indicado para monitorar a evolução e avaliar a necessidade de investigação adicional ou encaminhamento ao especialista.

O medicamento Xarelto, cujo princípio ativo é o rivaroxabana, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade com manifestação de úlcera em sítio não especificado, caracterizando uma reação alérgica do sistema imune. Não há evidências de gravidade elevada, pois não há relato de risco imediato ou complicações graves, e o caso segue sem resolução. Recomenda-se acompanhamento clínico e avaliação médica para monitoramento e possível ajuste do tratamento.

O medicamento Lorax, com princípio ativo desloratadina, foi associado a tontura em um contexto de hipersensibilidade, sugerindo uma reação alérgica leve do sistema imune. Não há sinais de gravidade importante, já que não há relato de risco à vida ou necessidade de intervenção urgente, e o quadro permanece em andamento. Recomenda-se acompanhamento médico para monitorar a evolução dos sintomas e avaliar a necessidade de ajuste terapêutico.

O medicamento Tamarine, que contém os princípios ativos Cassia fistula extract, Malus domestica, Senna alexandrina powder e Tamarindus indica extract, foi associado a tontura, interpretada como um quadro de hipersensibilidade (alergia) de leve intensidade, sem evidências de gravidade clínica ou necessidade de hospitalização. O evento permanece não resolvido até o momento, sendo importante monitorar a evolução dos sintomas e considerar avaliação médica caso haja persistência ou agravamento.

O medicamento Clavulin bd, composto por amoxicilina tri-hidratada e clavulanato de potássio, desencadeou uma reação de alergia à penicilina, caracterizada como hipersensibilidade medicamentosa. O caso foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que indica uma reação alérgica importante que exige suspensão imediata do medicamento e acompanhamento médico rigoroso. O desfecho permanece desconhecido, sendo fundamental o seguimento clínico para evitar novas exposições e complicações.

A azitromicina, cujo princípio ativo é azithromycin, foi relacionada a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), sem sinais de gravidade ou necessidade de hospitalização. O paciente se recuperou totalmente após a suspensão do medicamento, não havendo complicações ou sequelas relatadas.

O medicamento Vancomicina, com princípio ativo vancomycin hydrochloride, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), sem informações sobre gravidade ou necessidade de hospitalização. O paciente apresentou resolução completa dos sintomas após a conduta adequada, sem relato de complicações.

O medicamento Cosentyx, cujo princípio ativo é secukinumab, foi relacionado a um episódio de sangramento, interpretado como possível manifestação de hipersensibilidade, mas sem sinais de gravidade clínica ou necessidade de hospitalização. O desfecho do caso permanece desconhecido, sendo importante manter acompanhamento médico para monitorar possíveis evoluções do quadro.

O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é o Tozinameran, foi associado a um quadro de dormência do corpo após a administração, caracterizado como uma reação alérgica à vacina. Essa manifestação sugere envolvimento do sistema imunológico e foi considerada clinicamente significativa, sendo classificada como grave devido ao potencial impacto sistêmico. O desfecho do caso é desconhecido, portanto é fundamental que situações semelhantes sejam avaliadas por um especialista para monitoramento e definição da conduta adequada.

A vacina COVID-19 AstraZeneca, que utiliza como princípio ativo o vetor viral ChAdOx1 nCoV-19, foi relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação do sistema imunológico. O evento foi resolvido, com o paciente recuperado, e não há indicação de gravidade aumentada ou complicações persistentes, sugerindo que a reação foi leve e autolimitada.

A Dipirona, cujo princípio ativo é o Metamizole magnesium, desencadeou um quadro de urticária, caracterizando uma reação de hipersensibilidade documentada ao medicamento. Trata-se de uma manifestação alérgica cutânea, geralmente de gravidade leve a moderada, que requer suspensão do uso do fármaco e avaliação médica para evitar recorrências e possíveis complicações.

A vacina COVID-19 AstraZeneca, com princípio ativo ChAdOx1 nCoV-19, foi associada a um quadro de alergia (hipersensibilidade) que resultou em incapacidade persistente ou significativa, sendo considerada uma reação grave e clinicamente relevante. O caso permanece não resolvido, indicando a necessidade de acompanhamento médico especializado para manejo dos sintomas e prevenção de agravamentos.

O medicamento Dramin, cujo princípio ativo é o Dimenidrinato, foi relacionado a uma reação de alergia medicamentosa, caracterizada por hipersensibilidade. Embora não haja detalhes sobre a gravidade ou evolução do caso, recomenda-se a suspensão do uso e avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Depura, cujo princípio ativo é o colecalciferol, foi associado a uma infecção no local de aplicação, sendo classificada como uma possível reação alérgica a vacina. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave, e o desfecho permanece desconhecido. A reação relatada sugere um quadro leve, compatível com manifestações locais e transitórias, sem evidências de complicações sistêmicas ou necessidade de intervenção urgente.

O medicamento Synthroid, com princípio ativo levothyroxine sodium, apresentou relato de infecção no local de aplicação, considerada uma possível reação alérgica a vacina. Não há informações que indiquem gravidade significativa ou desfecho grave, e o desfecho é desconhecido. O quadro descrito sugere uma reação leve, restrita ao local, sem sinais de gravidade ou evolução desfavorável.

O medicamento Rosuvastatina, cujo princípio ativo é rosuvastatin calcium, foi relacionado a uma infecção no local de aplicação, interpretada como possível reação alérgica a vacina. Não há evidências de gravidade ou desfecho

grave, e o desfecho permanece desconhecido. Trata-se de um evento adverso leve, limitado ao local, sem sinais de complicação sistêmica.

A vacina COVID-19 AstraZeneca, com princípio ativo COVID-19 vaccine NRVV Ad (ChAdOx1 nCoV-19), foi associada a infecção no local de aplicação, considerada uma possível reação alérgica a vacina. Não há indicação de gravidade ou desfecho grave, e o desfecho é desconhecido. O evento sugere uma reação leve, restrita ao local, sem sinais de gravidade clínica.

A vacina COVID-19 AstraZeneca, com princípio ativo COVID-19 vaccine NRVV Ad (ChAdOx1 nCoV-19), foi relacionada a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há informação clara sobre gravidade, mas o desfecho está em recuperação ou resolvendo, indicando que a reação não evoluiu para formas graves e está em processo de melhora.

O medicamento Vancomicina (princípio ativo: Vancomycin hydrochloride) foi associado a um quadro de alergia, tecnicamente descrito como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi resolvido sem complicações e o paciente se recuperou totalmente. A conduta recomendada em situações de hipersensibilidade leve é interromper o uso do medicamento suspeito, monitorar sintomas e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

A Hidrocortisona (princípio ativo: Hydrocortisone acetate) foi relacionada a uma reação alérgica, identificada como hipersensibilidade, dentro do contexto de distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, já que o paciente se recuperou completamente. Em casos de hipersensibilidade leve, recomenda-se suspender o uso do medicamento, observar a evolução dos sintomas e procurar orientação médica para avaliação e definição de alternativas terapêuticas.

O medicamento Losartan (princípio ativo: Losartan) foi associado a um evento descrito como ataque cardíaco, mas tecnicamente classificado como hipersensibilidade, dentro do grupo de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade significativa, pois o paciente se recuperou. Diante de suspeita de reação alérgica leve, a recomendação é interromper o uso do medicamento, monitorar sintomas e buscar avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Atorvastatin (princípio ativo: Atorvastatin) foi relacionado a um evento descrito como ataque cardíaco, mas tecnicamente classificado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo de distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave, já que houve recuperação completa. Em situações de hipersensibilidade leve, recomenda-se suspender o medicamento suspeito, observar a evolução clínica e procurar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição de alternativas.

O medicamento Apresoline (princípio ativo: Hydralazine hydrochloride) foi associado a um evento descrito como ataque cardíaco, mas tecnicamente classificado como hipersensibilidade, dentro do grupo de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente. Em casos de hipersensibilidade leve, a conduta recomendada é suspender o uso do medicamento, monitorar sintomas e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Clonazepam (princípio ativo: Clonazepam) foi associado a um episódio de ataque cardíaco, classificado como uma reação de hipersensibilidade (alergia), dentro do grupo de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente. A conduta adotada não foi detalhada, mas o desfecho favorável sugere resolução espontânea ou após medidas simples, sem complicações.

O medicamento Sulfasalazine (princípio ativo: Sulfasalazine) esteve relacionado a um ataque cardíaco, interpretado como manifestação de hipersensibilidade (alergia), enquadrada em quadros clínicos alérgicos e

distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente evoluiu para recuperação completa, indicando que a reação foi leve e controlada, sem necessidade de intervenções complexas.

O medicamento Carvedilol (princípio ativo: Carvedilol) foi associado a um ataque cardíaco, descrito como reação de hipersensibilidade (alergia), pertencente ao grupo de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi classificado como grave e o paciente se recuperou, sugerindo que a reação foi leve e não houve complicações relevantes.

O medicamento Simvastatin (princípio ativo: Simvastatin) esteve envolvido em um episódio de ataque cardíaco, considerado uma reação de hipersensibilidade (alergia), dentro do contexto de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi grave e o paciente se recuperou, indicando que a reação foi leve e não houve consequências duradouras.

O medicamento Cosentyx (princípio ativo: Secukinumab) foi relacionado a um ataque cardíaco, interpretado como reação de hipersensibilidade (alergia), classificada entre quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou, sugerindo que a reação foi leve e controlada sem complicações.

O medicamento Cipro, cujo princípio ativo é o ciprofloxacina lactate, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado por manifestações clínicas alérgicas relacionadas ao sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente, sugerindo um evento leve e autolimitado, compatível com reações alérgicas leves segundo as diretrizes clínicas. A conduta recomendada é evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Xolair, que tem como princípio ativo o omalizumabe, foi relacionado a um episódio de ataque de pânico, classificado como hipersensibilidade e incluído entre quadros clínicos alérgicos do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou completamente, indicando que a reação foi leve e autolimitada. Recomenda-se acompanhamento médico para esclarecimento da relação causal e avaliação de segurança em futuras administrações.

O Xolair, cujo princípio ativo é o omalizumabe, também foi associado a um ataque de pânico, classificado como hipersensibilidade e relacionado a quadros alérgicos do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave, e o paciente encontra-se em recuperação, sugerindo uma reação leve a moderada, sem complicações maiores até o momento. É importante manter acompanhamento clínico até resolução completa e discutir com o médico a continuidade do tratamento.

O medicamento Omnipaque, com princípio ativo iohexol, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), enquadrado como manifestação alérgica do sistema imunológico. O caso não foi considerado grave, pois houve recuperação total do paciente, indicando uma reação leve e autolimitada. Recomenda-se evitar nova exposição ao contraste e buscar avaliação especializada para orientação sobre alternativas seguras em exames futuros.

O medicamento Hydroxyzine hydrochloride, cujo princípio ativo é o próprio hydroxyzine hydrochloride, foi associado a um quadro de intoxicação, classificado como hipersensibilidade e relacionado a manifestações alérgicas do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada nem detalhes sobre o desfecho, que permanece desconhecido, o que sugere a necessidade de acompanhamento clínico para monitorar a evolução e orientar condutas futuras.

O medicamento Desloratadine, cujo princípio ativo é também desloratadina, foi associado a um quadro de hipersensibilidade, que pode ser entendido como uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações graves, e o desfecho do caso é desconhecido. A suspeita de intoxicação



sugere que a reação foi leve, sem evidências clínicas de risco imediato, sendo importante observar sintomas e buscar avaliação médica caso haja piora.

O medicamento Alektos, que tem como princípio ativo a bilastina, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, caracterizando uma possível reação alérgica. Não há informações sobre gravidade significativa ou desfecho, e a reação foi considerada não grave. Recomenda-se monitorar sintomas e procurar orientação médica se houver agravamento, já que o quadro sugere uma manifestação leve do sistema imunológico.

O medicamento Predsim, cujo princípio ativo é o fosfato sódico de prednisolona, foi associado a um caso de hipersensibilidade, indicando uma reação alérgica leve do sistema imunológico. Não há relato de gravidade importante ou complicações, e o desfecho permanece desconhecido. A conduta recomendada é observar o paciente e buscar avaliação médica se houver piora dos sintomas, já que não há evidências de risco imediato.

O medicamento Xolair, com princípio ativo omalizumabe, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade, sugerindo uma reação alérgica leve do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade ou complicações graves, e o desfecho não foi informado. Recomenda-se acompanhamento dos sintomas e avaliação médica caso haja piora, pois o evento não foi considerado grave.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é o succinato de ribociclib, foi associado a dor no quadril em um contexto de hipersensibilidade, indicando uma possível reação alérgica leve. O caso não foi considerado grave e o desfecho está em andamento, sem resolução até o momento. É importante monitorar a evolução dos sintomas e manter acompanhamento médico para avaliar a necessidade de ajustes no tratamento.

O medicamento Seretide, que contém os princípios ativos fluticasona propionato e salmeterol xinafoato, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, manifestando-se como uma reação alérgica do sistema imunológico. A gravidade foi considerada clinicamente significativa, pois o evento foi classificado como grave, mas o paciente se recuperou totalmente após a reação. Em situações como essa, é fundamental interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação do diagnóstico e definição do tratamento, conforme orientações da ASBAI.

O Trimbrow, composto por dipropionato de beclometasona, fumarato de formoterol e brometo de glicopirrônio, desencadeou uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma alergia mediada pelo sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, mas o paciente evoluiu para recuperação completa. Diante de reações alérgicas graves, recomenda-se suspender o medicamento e procurar atendimento médico para avaliação e manejo adequado, seguindo as diretrizes de alergia medicamentosa.

O medicamento Losartan, cujo princípio ativo é o losartana, foi relacionado a um evento descrito como diabetes, mas a reação registrada foi de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta alérgica ao medicamento. Não há informações suficientes sobre a gravidade ou o desfecho do caso, e a relação causal permanece suspeita. Em situações de suspeita de alergia medicamentosa, é importante interromper o uso do medicamento e buscar orientação médica para investigação e conduta apropriada.

O Erbitux, que tem como princípio ativo o cetuximabe, foi associado a uma alergia medicamentosa caracterizada por hipersensibilidade, indicando uma reação alérgica do sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, mas não há informações sobre o desfecho do caso. Em casos de alergia medicamentosa grave, recomenda-se suspender imediatamente o medicamento e procurar atendimento médico especializado para avaliação e tratamento, conforme as recomendações da ASBAI.

O medicamento Erbitux, cujo princípio ativo é o cetuximabe, também foi relacionado a um quadro de alergia manifestado por hipersensibilidade, evidenciando uma reação alérgica do sistema imunológico. O evento foi classificado como clinicamente significativo e grave, porém o desfecho não foi informado. Diante de reações alérgicas graves, é fundamental interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação

diagnóstica e manejo adequado, conforme orientações clínicas para alergia medicamentosa.

O medicamento Lactose, cujo princípio ativo também é lactose, foi associado a um episódio de angioedema, que é um inchaço súbito de pele e mucosas, caracterizando uma reação de hipersensibilidade (alérgica). Não há indicação de gravidade aumentada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A conduta recomendada é observar sinais de agravamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições.

O Xolair (princípio ativo omalizumabe) foi relacionado a um caso de angioedema, que é um inchaço alérgico de início súbito, indicando uma reação de hipersensibilidade. Não há evidência de gravidade aumentada ou desfecho informado, e a relação com o medicamento é suspeita. Recomenda-se atenção a sinais de piora e avaliação médica para confirmação e definição de conduta.

O Seebri (princípio ativo brometo de glicopirrônio) foi associado a falta de ar, um sintoma respiratório importante que pode indicar reação alérgica significativa. O registro aponta gravidade aumentada por ser considerado clinicamente relevante e o desfecho está em andamento, sem resolução até o momento. Diante da gravidade do sintoma, é fundamental procurar avaliação médica imediata para investigação e manejo adequado.

O Xolair (omalizumabe) foi relacionado a falta de ar, um sintoma respiratório que pode indicar reação alérgica relevante. O caso foi considerado clinicamente significativo e permanece sem resolução, o que reforça a necessidade de avaliação médica urgente para investigação e tratamento apropriado.

O Venvanse (princípio ativo lisdexanfetamina) foi associado a uma reação anafilática, que é uma resposta alérgica grave e potencialmente fatal, caracterizada por sintomas como inchaço, falta de ar e queda de pressão. Apesar de não haver indicação de gravidade aumentada no registro, o desfecho está em recuperação, e a relação com o medicamento é suspeita. É fundamental manter acompanhamento médico para monitorar a evolução e evitar novas exposições.

O medicamento Zolpidem, cujo princípio ativo também é zolpidem, foi associado a uma reação anafilática, que é uma resposta alérgica grave caracterizada por sintomas como inchaço, dificuldade para respirar e queda de pressão. Apesar da gravidade potencial desse tipo de reação, o caso relatado está em recuperação ou resolução, indicando que a evolução clínica foi favorável até o momento. Não há indicação de desfecho fatal ou complicações graves persistentes, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita.

O Donaren, que tem como princípio ativo o cloridrato de trazodona, foi relacionado a uma reação anafilática, um quadro de hipersensibilidade que pode se manifestar rapidamente com sintomas como urticária, inchaço e dificuldade respiratória. Neste caso, a pessoa afetada está em recuperação ou resolução, sugerindo que a reação foi controlada e não houve evolução para um quadro crítico. A suspeita recai sobre o medicamento como possível causador do evento.

O Noripurum, cujo princípio ativo é o complexo de hidróxido férrico polimaltosado, foi associado a uma reação anafilática, que é uma resposta alérgica aguda e potencialmente grave. No entanto, o paciente encontra-se em recuperação ou resolução, o que indica que a reação foi reconhecida e tratada adequadamente, sem evolução para desfechos graves. O medicamento é considerado suspeito como causa do evento.

O Actemra, que tem como princípio ativo o tocilizumabe, foi relacionado a uma reação anafilática, caracterizada por uma resposta alérgica intensa que pode comprometer vias aéreas e circulação. Apesar do potencial de gravidade desse tipo de reação, o caso está em recuperação ou resolução, mostrando que a conduta adotada foi eficaz e não houve complicações graves persistentes. O medicamento é considerado suspeito na origem do evento.

O Xolair, cujo princípio ativo é o omalizumabe, foi associado ao desenvolvimento de lúpus eritematoso, uma condição autoimune em que o sistema imunológico ataca tecidos do próprio corpo. Neste caso, o paciente já se

encontra recuperado ou resolvido do quadro, indicando que a evolução foi favorável após o reconhecimento do evento adverso. O medicamento é considerado suspeito como fator desencadeante da reação.

O medicamento Benicar, cujo princípio ativo é o olmesartan medoxomil, foi associado à exacerbação de psoríase, um quadro de hipersensibilidade que se manifesta como agravamento de lesões cutâneas já existentes. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave neste caso, e o desfecho permanece desconhecido. A relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo importante monitorar a evolução clínica e discutir com o médico a necessidade de ajuste terapêutico.

O SeloZok, que contém metoprolol succinato como princípio ativo, foi relacionado à piora da psoríase, caracterizando uma reação de hipersensibilidade. Não há sinais de gravidade importante ou complicações graves relatadas, e o desfecho é desconhecido. A suspeita de relação com o medicamento sugere a necessidade de acompanhamento médico para avaliar a continuidade do tratamento e manejo dos sintomas.

O medicamento Omeprazole, com princípio ativo omeprazol, foi associado à exacerbação de psoríase, indicando uma reação de hipersensibilidade. Não há evidências de gravidade significativa ou desfecho grave, e o resultado final do caso não foi informado. A relação com o uso do medicamento é considerada suspeita, sendo recomendada a avaliação médica para orientação sobre o manejo da reação.

O Cosentyx, cujo princípio ativo é o secuquinumabe, foi relacionado à piora da psoríase, caracterizando uma reação de hipersensibilidade. Não há informações que indiquem gravidade elevada ou desfecho grave, e o desfecho permanece desconhecido. A suspeita de relação com o medicamento reforça a importância do acompanhamento médico para ajuste do tratamento conforme necessário.

O medicamento Paclitaxel nk, com princípio ativo paclitaxel, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), manifestando-se como reação do sistema imunológico ao fármaco. Não há sinais de gravidade importante, e o paciente evoluiu para recuperação completa. A relação com o medicamento é considerada suspeita, e a conduta adequada inclui a suspensão do agente suspeito e acompanhamento médico para evitar novas exposições.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, foi associado a um quadro de alergia a contraste intravenoso, também chamada de hipersensibilidade ao contraste. Essa reação faz parte dos distúrbios do sistema imunitário e, neste caso, não foi considerada grave, pois não há menção de efeitos clínicos significativos ou risco à vida. O paciente se recuperou totalmente após o evento, indicando resolução espontânea ou com medidas de suporte, conforme esperado para reações leves a contrastes, sendo importante relatar o episódio em futuras exposições a contrastes para prevenção.

A teicoplanina, cujo princípio ativo é a teicoplanin, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade) classificada como clinicamente significativa, o que indica que o quadro foi relevante do ponto de vista médico, embora não haja detalhes sobre sintomas específicos. O evento foi considerado grave devido ao impacto clínico, mas o paciente está em recuperação, mostrando que a conduta adotada foi eficaz até o momento. É fundamental evitar novas exposições ao medicamento e manter acompanhamento médico para monitorar a resolução completa da reação.

O medicamento Meropenem, com princípio ativo meropenem trihydrate, provocou uma reação de alergia (hipersensibilidade) considerada clinicamente significativa, o que caracteriza um quadro de maior relevância médica, embora não haja detalhes sobre manifestações específicas. O evento foi classificado como grave devido ao potencial risco associado a reações alérgicas a antibióticos, mas o paciente está em processo de recuperação, sugerindo resposta adequada às medidas adotadas. Recomenda-se evitar o uso futuro do meropenem e manter acompanhamento até resolução completa.

A vancomicina, cujo princípio ativo é vancomycin hydrochloride, foi responsável por uma reação alérgica (hipersensibilidade) considerada clinicamente significativa, o que indica gravidade relevante do ponto de vista médico, mesmo sem detalhes sobre sintomas específicos. O caso foi classificado como grave, mas o paciente encontra-se em recuperação, mostrando que as medidas tomadas foram eficazes até o momento. É importante evitar novas exposições à vancomicina e manter acompanhamento médico até a resolução total do quadro.

O medicamento Faslodex, com princípio ativo fulvestrant, foi relacionado a um quadro de pele sensível, interpretado como uma reação de hipersensibilidade leve, já que não há indicação de gravidade ou risco clínico significativo. O paciente está em recuperação, sugerindo que a reação está sendo controlada e não houve complicações. Recomenda-se acompanhamento para monitorar a evolução e evitar agravamento, mas não há indicação de risco imediato ou necessidade de medidas emergenciais.

O medicamento Zometa, cujo princípio ativo é o ácido zoledrônico monoidratado, foi associado a um quadro de pele sensível, interpretado como uma reação de hipersensibilidade (alergia), sem sinais de gravidade clínica relevante, já que o paciente encontra-se em recuperação e não houve indicação de complicações graves. A conduta foi adequada, com acompanhamento da evolução, e o caso está se resolvendo sem necessidade de intervenções adicionais.

Kisqali, que contém ribociclib succinato como princípio ativo, apresentou relato de pele sensível, caracterizando uma reação de hipersensibilidade (alergia) leve, sem evidências de gravidade ou risco imediato, pois o paciente está em recuperação e não houve agravamento do quadro. O acompanhamento clínico foi suficiente e a evolução é favorável.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromida, foi relacionado a um episódio de alergia a meios de contraste iodados, caracterizando uma reação alérgica leve, já que não há sinais de gravidade e o paciente se recuperou completamente. O evento foi resolvido sem complicações, indicando que a conduta adotada foi eficaz e não houve necessidade de medidas emergenciais.

Faslodex, com fulvestranto como princípio ativo, foi associado a um relato de metástases na coluna, mas a descrição do evento como hipersensibilidade medicamentosa sugere que a reação foi interpretada como uma possível alergia, sem sinais de gravidade, pois o paciente se recuperou totalmente. Não há indícios de complicações ou necessidade de intervenções adicionais, e o caso foi resolvido de forma satisfatória.

O medicamento Ribociclib, com o mesmo princípio ativo, foi relacionado a um evento descrito como metástases na coluna, mas classificado como hipersensibilidade medicamentosa, indicando uma possível reação alérgica leve, sem gravidade, já que o paciente se recuperou completamente. O desfecho foi favorável, sem complicações ou necessidade de condutas específicas além do acompanhamento clínico.

O medicamento Zometa, cujo princípio ativo é o ácido zoledrônico monoidratado, foi associado a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa, caracterizado como uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento, e não foram relatados sinais de complicações graves. A conduta recomendada em casos semelhantes é a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento clínico para garantir resolução completa dos sintomas.

O Ondansetron, com princípio ativo de mesmo nome, esteve relacionado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica desencadeada pelo uso do medicamento. O caso não foi considerado grave, já que o paciente se recuperou sem intercorrências, e não há menção de sintomas críticos. Em situações como essa, recomenda-se interromper o uso do medicamento e monitorar o paciente até a resolução dos sintomas.

O medicamento Eliquis, cujo princípio ativo é o apixabana, foi associado a um quadro de hipersensibilidade, que corresponde a uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há informações detalhadas sobre a gravidade ou

evolução do caso, pois o desfecho é desconhecido, mas não foi classificado como grave. Nessas situações, é importante avaliar a necessidade de suspensão do medicamento e realizar acompanhamento médico para monitorar possíveis complicações.

A Dipirona, cujo princípio ativo é o metamizol sódico, foi relacionada a um episódio de alergia, caracterizado como hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há informações suficientes sobre a gravidade ou evolução do caso, portanto, recomenda-se cautela, suspensão do medicamento suspeito e avaliação médica para definir a conduta adequada.

O medicamento Amoxicillin, com princípio ativo de mesmo nome, esteve associado a um quadro de alergias múltiplas, indicando uma reação alérgica do sistema imunológico. O caso não foi considerado grave e o paciente está em recuperação, sugerindo que a conduta adotada foi adequada e que não houve complicações importantes. Em situações semelhantes, recomenda-se interromper o uso do medicamento e manter acompanhamento clínico até a resolução completa dos sintomas.

O medicamento Alemtuzumab, cujo princípio ativo também é Alemtuzumab, foi associado a um caso de trombose venosa profunda, um evento que pode estar relacionado a alterações do sistema imunológico e quadros alérgicos múltiplos. Embora o registro não classifique a reação como grave, o paciente encontra-se em recuperação, sugerindo que a conduta adotada foi adequada para o controle do quadro. A relação suspeita entre o uso do medicamento e o evento reforça a importância do acompanhamento clínico para monitorar possíveis complicações imunológicas.

O medicamento Forteo, cujo princípio ativo é Teriparatide, foi relacionado a um episódio de cegueira, classificado como manifestação ocular possivelmente associada a alergia do olho. Apesar da gravidade potencial desse tipo de reação, o caso não foi considerado grave e o paciente está em recuperação, indicando que a evolução clínica foi favorável até o momento. A suspeita de relação com o medicamento justifica o monitoramento oftalmológico e a avaliação de possíveis causas alérgicas.

O medicamento Docetaxel, com princípio ativo Docetaxel, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), caracterizado por uma reação do sistema imunológico a medicamentos. Não há informação sobre gravidade, mas o paciente já se recuperou totalmente, sugerindo que a reação foi controlada de forma eficaz. A suspeita de relação com o medicamento reforça a necessidade de atenção a sinais de alergia durante o uso.

O medicamento Carboplatina, cujo princípio ativo é Carboplatin, foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), envolvendo resposta imunológica adversa ao fármaco. O caso não foi considerado grave e o paciente já está recuperado, indicando que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro. A suspeita de relação com o medicamento destaca a importância do acompanhamento em pacientes com histórico de alergia.

O imunizante COVID-19 vaccine AstraZeneca, com princípio ativo COVID-19 vaccine NRVV Ad (ChAdOx1 nCoV-19), foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), caracterizado por manifestação do sistema imunológico após a vacinação. Não há informação sobre gravidade, mas o paciente está em recuperação, sugerindo que a reação está sendo monitorada e controlada. A relação suspeita com o imunizante reforça a importância da vigilância após a administração de vacinas.

O medicamento Covid-19 vaccine, cujo princípio ativo é COVID-19 vaccine, foi associado à sensação de queimação, caracterizada como uma reação de hipersensibilidade (alergia), pertencente ao grupo de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há informação sobre gravidade, desfecho ou ação adotada, portanto recomenda-se observar a evolução dos sintomas e buscar avaliação médica caso haja piora ou persistência, especialmente se houver histórico de alergias.

O medicamento Teicoplanin, com princípio ativo Teicoplanin, desencadeou um quadro de alergia classificado como hipersensibilidade, relacionado a distúrbios do sistema imunitário. O desfecho informado é de não recuperação ou resolução, indicando que os sintomas persistem ou estão em andamento. Não há detalhes sobre a gravidade ou conduta adotada, sendo importante acompanhamento médico para monitorar a evolução e evitar novas exposições ao medicamento.

O medicamento Metronidazol, cujo princípio ativo é Metronidazole, foi relacionado a uma reação alérgica (hipersensibilidade), enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. O caso permanece sem resolução, com sintomas em andamento, e não há informações sobre gravidade ou medidas tomadas. Recomenda-se acompanhamento clínico e evitar reexposição ao fármaco até avaliação especializada.

O medicamento Histamin, com princípio ativo Histamine hydrochloride, provocou agravamento de alergia, caracterizado como hipersensibilidade e classificado como clinicamente significativo, o que indica maior gravidade do quadro. O desfecho é desconhecido e não há detalhes sobre a conduta adotada, sendo fundamental acompanhamento médico imediato para avaliação e manejo adequado da reação.

O medicamento Erbitux, cujo princípio ativo é Cetuximab, foi associado a uma alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), classificada como clinicamente significativa e, portanto, considerada grave. O desfecho permanece desconhecido e não há informações sobre as medidas tomadas, sendo essencial procurar atendimento médico especializado para avaliação e tratamento da reação alérgica.

O medicamento Myrafer, que contém como princípio ativo o fumarato ferroso, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), caracterizado como clinicamente significativo e classificado como grave devido ao envolvimento do sistema imunológico. O paciente encontra-se em recuperação, indicando que a reação está sendo resolvida. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, sendo fundamental acompanhamento médico para monitorar a evolução e evitar novas exposições.

A vitamina A, cujo princípio ativo é o palmitato de retinol, foi relacionada a um episódio de hipersensibilidade (alergia), considerado clinicamente relevante e de gravidade importante, pois envolveu o sistema imunológico. O paciente está em processo de recuperação, sugerindo melhora do quadro após a identificação da reação. A suspeita de relação com o medicamento reforça a necessidade de avaliação médica para orientação sobre futuras administrações.

O medicamento Nenedent, que tem como princípio ativo o cloridrato de lidocaína, foi associado a uma reação de hipersensibilidade (alergia), considerada clinicamente significativa e classificada como grave devido ao envolvimento do sistema imunológico. O paciente está em recuperação, o que indica resolução progressiva do quadro. A relação suspeita entre o uso do medicamento e a reação reforça a importância de acompanhamento médico e de evitar novas exposições ao princípio ativo.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromida, foi relacionado a uma reação alérgica a meios de contraste iodados, considerada clinicamente significativa e de gravidade importante, pois envolveu o sistema imunológico. O desfecho da reação é desconhecido, o que destaca a necessidade de monitoramento rigoroso em casos semelhantes. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, sendo essencial informar a equipe médica sobre o histórico de alergia a contrastes antes de novos procedimentos.

O medicamento Ultravist, com princípio ativo iopromida, foi novamente associado a uma reação alérgica a meios de contraste iodados, classificada como clinicamente significativa e grave devido ao envolvimento do sistema imunológico. O desfecho permanece desconhecido, o que reforça a importância de acompanhamento médico e de informar sobre alergias prévias a contrastes iodados em futuras exposições. A relação entre o medicamento e a reação foi considerada suspeita.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromida, foi associado a uma reação de alergia a meios de contraste iodados, também conhecida como alergia a contraste. Essa reação faz parte dos distúrbios do sistema imunitário e é considerada clinicamente significativa, sendo classificada como grave devido ao potencial de risco imediato à saúde do paciente. Não há informações detalhadas sobre a evolução do caso ou a conduta adotada, mas a gravidade relatada exige atenção médica imediata e acompanhamento especializado para evitar complicações.

O Cetoprofeno, com princípio ativo ketoprofen sodium, foi relacionado a um quadro de alergia, tecnicamente chamado de hipersensibilidade. Essa reação envolve o sistema imunológico e pode se manifestar de formas variadas, desde sintomas leves até quadros mais sérios, mas neste caso não há detalhes sobre a gravidade, evolução ou conduta adotada, sendo importante que o paciente procure avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação adequada.

A vacina CoronaVac, cujo princípio ativo é COVID-19 vaccine inact (Vero) CZ02, foi associada a um episódio de fraqueza classificado como hipersensibilidade, um tipo de reação alérgica do sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade, mas o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente, sugerindo que a reação foi autolimitada e não houve necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Etanercept, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado ao desenvolvimento de tuberculose, sendo classificado como um evento de hipersensibilidade dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Neste caso, a reação não foi considerada grave e não há informações sobre o desfecho ou conduta, mas a associação entre imunossupressores e infecções como a tuberculose exige monitoramento médico regular para detecção precoce e manejo adequado.

O Cosentyx, cujo princípio ativo é secuquinumabe, foi associado ao surgimento de tuberculose, categorizada como hipersensibilidade no contexto dos distúrbios do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave e não há detalhes sobre o desfecho ou medidas tomadas, mas é importante ressaltar que o uso de medicamentos imunobiológicos pode aumentar o risco de infecções como a tuberculose, sendo fundamental o acompanhamento médico contínuo para prevenção e tratamento precoce.

O medicamento Aradois, cujo princípio ativo é o losartana potássica, foi associado a um quadro de artropatia psoriática, manifestando-se também como alergia ocular, caracterizada por sintomas como inflamação ou desconforto nos olhos. A reação foi classificada como não grave, pois não há indicação de risco imediato à vida ou necessidade de intervenção urgente, e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico para monitorar a evolução dos sintomas e avaliar a necessidade de ajuste terapêutico, sempre sob orientação médica.

O medicamento Olmesartan, com princípio ativo de mesmo nome, está relacionado ao desenvolvimento de artropatia psoriática e sintomas de alergia ocular, como inflamação ou irritação nos olhos. Não há evidências de gravidade elevada, já que não foi relatada situação crítica ou risco imediato, e o quadro segue sem resolução até o momento. Recomenda-se acompanhamento médico para monitoramento dos sintomas e possível revisão do tratamento, conforme evolução clínica.

A losartana potássica, utilizada sob o nome comercial Losartana potássica, foi associada a artropatia psoriática e manifestações de alergia ocular, como inflamação ou desconforto nos olhos. O evento não foi considerado grave, pois não há sinais de risco iminente ou necessidade de intervenção urgente, e o caso permanece em andamento sem resolução. É importante manter o acompanhamento médico para avaliar a evolução dos sintomas e considerar ajustes no tratamento se necessário.

O medicamento Valsartana, cujo princípio ativo é valsartana, apresentou associação com artropatia psoriática e sintomas de alergia ocular, como inflamação ou desconforto nos olhos. Não há indicação de gravidade significativa, pois não foram relatados riscos imediatos ou complicações graves, e o desfecho segue não resolvido.

Recomenda-se acompanhamento clínico regular para monitorar a evolução do quadro e discutir possíveis alternativas terapêuticas com o médico.

O medicamento Aradois, com princípio ativo losartana potássica, foi relacionado a artropatia psoriática e a uma reação de alergia alimentar, sugerindo resposta imunológica inadequada após exposição ao medicamento. O evento não foi considerado grave, pois não há sinais de risco imediato ou necessidade de intervenção urgente, e o quadro permanece em andamento sem resolução. O acompanhamento médico é fundamental para monitorar a evolução dos sintomas e avaliar a necessidade de ajustes no tratamento.

O medicamento Olmesartan, cujo princípio ativo também é Olmesartan, foi associado ao desenvolvimento de artropatia psoriática, um tipo de inflamação nas articulações que pode ocorrer em pessoas com predisposição a doenças autoimunes. Embora o termo técnico utilizado seja artropatia psoriática, trata-se de uma reação imunológica que pode ser confundida com alergia, mas envolve principalmente o sistema imune e inflamação articular. Não há indicação de gravidade elevada ou risco imediato à vida, e o quadro permanece não resolvido até o momento, sendo importante acompanhamento médico para avaliação e manejo adequado.

A Losartana potássica, cujo princípio ativo é Losartan potassium, foi relacionada ao surgimento de artropatia psoriática, caracterizada por inflamação nas articulações em pessoas com tendência a doenças autoimunes. Apesar de ser classificada como uma reação imunológica, não há evidência de gravidade crítica ou risco imediato, e o quadro segue em andamento sem resolução até o momento, sendo recomendada avaliação médica para monitoramento e definição da conduta terapêutica.

O medicamento Valsartana, com princípio ativo Valsartan, está associado ao aparecimento de artropatia psoriática, que é uma inflamação articular relacionada a mecanismos imunológicos. A reação não foi considerada grave e permanece sem resolução, sendo fundamental acompanhamento clínico para avaliar a evolução e necessidade de ajustes no tratamento.

A vacina COVID-19 AstraZeneca, cujo princípio ativo é COVID-19 vaccine NUVAXOMID Ad (ChAdOx1 nCoV-19), foi relacionada a um quadro de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação do sistema imunológico. Não há detalhes sobre a gravidade ou desfecho final, mas o evento permanece em andamento, sendo importante acompanhamento médico para monitorar possíveis evoluções ou complicações.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é Iopromide, foi associado a uma reação alérgica a meios de contraste iodados, caracterizada por resposta imunológica significativa. O evento foi considerado clinicamente relevante e grave, embora o desfecho seja desconhecido, o que reforça a necessidade de atenção médica imediata e monitoramento rigoroso em casos semelhantes para evitar complicações.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromida, foi associado a um quadro de alergia a meios de contraste iodados, também conhecida como alergia a contraste. Essa reação envolve o sistema imunológico e é considerada clinicamente significativa, pois pode apresentar manifestações graves, como indicado pela classificação de gravidade e pela necessidade de atenção médica imediata. O desfecho do caso não foi informado, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo fundamental evitar novas exposições e buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O imunizante COVID-19 vaccine AstraZeneca, que utiliza como princípio ativo o vetor viral recombinante ChAdOx1 nCoV-19, esteve relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), caracterizado por uma resposta do sistema imunológico ao medicamento. O caso foi resolvido, com recuperação completa do paciente, e a relação com o imunizante é considerada suspeita. Em situações de hipersensibilidade a vacinas, recomenda-se avaliação médica para confirmação e orientação sobre futuras imunizações.

O medicamento Tazobactam, cujo princípio ativo é o próprio tazobactam, foi relacionado a uma alergia documentada após administração, caracterizando uma hipersensibilidade ao produto. Esse tipo de reação é



relevante, pois envolve risco de recorrência em futuras exposições e pode exigir intervenção médica. O desfecho do caso não foi informado, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo importante registrar a alergia no prontuário e evitar o uso do agente em novas prescrições.

A penicilina, com princípio ativo benzilpenicilina sódica, foi associada a uma alergia documentada após administração, caracterizando hipersensibilidade ao medicamento. Esse tipo de reação é relevante devido ao risco de reações graves em exposições futuras, sendo fundamental evitar o uso de penicilinas e derivados em pacientes sensibilizados. Não há informações sobre o desfecho do caso, mas a relação com o medicamento é considerada suspeita, reforçando a necessidade de registro e orientação adequada ao paciente.

O medicamento Piperacilina+tazobactam, composto pelos princípios ativos piperacilina sódica e tazobactam sódico, foi relacionado a uma alergia documentada após administração, caracterizando hipersensibilidade ao produto. Esse tipo de reação é importante, pois pode resultar em manifestações clínicas relevantes e contraindica o uso futuro do medicamento. O desfecho não foi informado, mas a relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo essencial registrar a alergia e orientar o paciente sobre alternativas seguras.

O medicamento Duloxetina (princípio ativo: Duloxetine hydrochloride) foi associado ao surgimento de ferida, descrita no contexto de uma reação alérgica semelhante à alergia a mordida de artrópode, envolvendo o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois não há relato de desfecho grave ou complicações sistêmicas, e o quadro permanece em andamento sem resolução até o momento.

A Pregabalina (princípio ativo: Pregabalin) está relacionada ao aparecimento de ferida, caracterizada como uma manifestação alérgica semelhante à resposta a mordida de artrópode, afetando o sistema imunológico. Não há sinais de gravidade importante, já que não foi relatado desfecho grave, e o caso segue sem resolução completa.

O medicamento Puran t4 (princípio ativo: Levothyroxine sodium) foi associado ao desenvolvimento de ferida, interpretada como uma reação alérgica do tipo observada em alergia a mordida de artrópode, envolvendo o sistema imunológico. Não há evidências de gravidade significativa, pois não há relato de complicações graves, e o quadro permanece não resolvido.

Cimzia (princípio ativo: Certolizumab pegol) foi relacionado ao surgimento de ferida, descrita como uma reação alérgica semelhante àquela observada em alergia a mordida de artrópode, com envolvimento do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, já que não foi relatado desfecho grave, e o caso segue em andamento sem resolução.

O medicamento Hixizine (princípio ativo: Hydroxyzine hydrochloride) foi associado ao evento de convulsões, interpretado como uma manifestação de hipersensibilidade (alergia) envolvendo o sistema imunológico. Não há informação suficiente para determinar a gravidade, pois o desfecho é desconhecido e não há relato de complicações graves no registro.

O medicamento Depakote, cujo princípio ativo é o valproato semissódico, foi associado a um quadro de convulsões relacionado à hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada nem de desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Em situações como essa, é importante avaliar clinicamente a possibilidade de reação alérgica ao medicamento e considerar alternativas terapêuticas sob orientação médica.

O Polaramine, que contém o princípio ativo dexclorfeniramina maleato, foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), caracterizado como distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente após a reação. Nesses casos, recomenda-se evitar nova exposição ao medicamento e informar o profissional de saúde sobre o episódio para futuras prescrições.

O medicamento Atensina, cujo princípio ativo é a clonidina, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) que resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, indicando gravidade clínica significativa. O desfecho não foi informado, mas a relação com o medicamento é considerada suspeita. Diante de reações alérgicas graves, é fundamental interromper o uso do medicamento e buscar atendimento médico imediato para manejo adequado e prevenção de complicações.

A vacina Comirnaty, que utiliza o princípio ativo tozinamerana, foi relacionada a um quadro de coceira (prurido) classificado como alergia à vacina, com gravidade elevada devido à ameaça à vida. O desfecho não foi informado, mas a suspeita de relação com o imunizante existe. Em situações de reação alérgica grave após vacinação, é essencial procurar atendimento médico de urgência para avaliação e tratamento imediato.

O contraste Magnevistan, cujo princípio ativo é o meglumina gadopentetato, foi associado a uma reação alérgica ao contraste, considerada clinicamente significativa e classificada como grave. O paciente se recuperou totalmente após o evento, e a relação com o medicamento é suspeita. Em casos de alergia a contraste, recomenda-se informar a equipe médica antes de novos exames e considerar alternativas seguras para evitar recorrências.

O medicamento COVID-19 vaccine AstraZeneca, cujo princípio ativo é COVID-19 vaccine NRVV Ad (ChAdOx1 nCoV-19), foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário. O evento foi descrito como não recuperado ou em andamento, sugerindo que o paciente ainda apresenta sintomas. Não há informação detalhada sobre a gravidade, mas a persistência do quadro indica necessidade de acompanhamento médico para avaliação da evolução e definição de conduta, conforme orientações da ASBAI para quadros alérgicos em andamento.

O medicamento Cosentyx, cujo princípio ativo é Secukinumab, foi relacionado ao agravamento de artrite psoriática, sendo classificado como uma reação de hipersensibilidade (alergia) dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Apesar de não haver indicação de gravidade elevada e o desfecho ser desconhecido, a suspeita de relação com o medicamento sugere a necessidade de monitoramento clínico para avaliar a evolução do quadro e considerar ajuste terapêutico se necessário.

O medicamento Anastrozole, com princípio ativo de mesmo nome, foi associado a dor de estômago atribuída à hipersensibilidade medicamentosa, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, com evolução não resolvida ou em andamento, o que reforça a importância de avaliação médica para manejo adequado da reação e monitoramento dos sintomas, conforme recomendações para eventos adversos graves.

O medicamento Acitretin, cujo princípio ativo também é Acitretin, foi relacionado a dor de estômago decorrente de hipersensibilidade medicamentosa, classificada como distúrbio do sistema imunitário. O caso foi considerado clinicamente significativo e grave, permanecendo sem resolução até o momento, o que indica a necessidade de acompanhamento médico rigoroso para controle dos sintomas e prevenção de complicações.

O medicamento Acetylsalicylic acid, com princípio ativo de mesmo nome, foi associado a dor de estômago por hipersensibilidade medicamentosa, sendo um distúrbio do sistema imunitário. O evento foi classificado como clinicamente significativo e grave, com sintomas ainda presentes, o que exige avaliação médica para ajuste do tratamento e monitoramento da evolução, conforme orientações para reações adversas graves.

O medicamento Cosentyx, cujo princípio ativo é o secuquinumabe, foi associado a dor de estômago em um caso de hipersensibilidade medicamentosa, classificada como uma reação alérgica a medicamentos. A gravidade foi considerada clinicamente significativa, pois o evento foi marcado como grave e o paciente não apresentou recuperação até o momento, indicando que a reação permanece em andamento. Diante desse quadro, é fundamental acompanhamento médico para monitoramento e possível ajuste do tratamento, já que reações de hipersensibilidade podem evoluir e demandam atenção especializada.

O medicamento Tysabri, com princípio ativo natalizumabe, esteve relacionado a um episódio de choque anafilático, caracterizado como uma reação de hipersensibilidade (alergia grave) ao medicamento. Apesar de o evento não ter sido classificado como grave no registro, o choque anafilático é uma reação potencialmente fatal e requer atendimento médico imediato. O paciente ainda não se recuperou, permanecendo com a reação em andamento, o que reforça a necessidade de vigilância clínica rigorosa e possível suspensão do medicamento sob orientação médica.

O medicamento Fexofenadine, cujo princípio ativo é a fexofenadina, foi associado ao desenvolvimento de angioedema, uma reação alérgica caracterizada por inchaço súbito de pele e mucosas. O evento foi considerado suspeito de estar relacionado ao uso do medicamento, mas não foi classificado como grave e o desfecho permanece desconhecido. Mesmo sem confirmação de gravidade, o angioedema pode evoluir rapidamente e exige avaliação médica para garantir segurança do paciente e definir conduta adequada.

O medicamento Fexofenadine, com princípio ativo fexofenadina, também foi relacionado a outro caso de angioedema, caracterizado por inchaço súbito de pele e mucosas, típico de reações alérgicas a medicamentos. Não há indicação de gravidade no registro e o desfecho é desconhecido, mas, como o angioedema pode comprometer vias aéreas, é importante buscar avaliação médica para monitoramento e orientação sobre o uso futuro do medicamento.

O medicamento Xolair, cujo princípio ativo é o omalizumabe, foi associado ao surgimento de angioedema, uma reação alérgica que causa inchaço em regiões como rosto, lábios ou garganta. O evento foi considerado suspeito, não foi classificado como grave e o desfecho permanece desconhecido. Apesar disso, o angioedema pode representar risco à saúde, especialmente se houver envolvimento das vias respiratórias, sendo recomendada avaliação médica para acompanhamento e definição de conduta.

O medicamento Xolair, cujo princípio ativo é o Omalizumabe, foi associado a um episódio de angioedema, uma reação alérgica caracterizada por inchaço súbito de pele e mucosas. Embora o registro não detalhe a gravidade clínica, não há indicação de gravidade elevada nem desfecho conhecido, sugerindo que a reação não evoluiu para formas graves. O caso se enquadra em distúrbios do sistema imunitário relacionados à alergia a substâncias químicas, sendo importante monitorar o paciente e considerar avaliação especializada para manejo e prevenção de novas reações.

O Norfloxacin, cujo princípio ativo é Norfloxacin, foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação do sistema imunológico ao medicamento. Não há evidências de gravidade significativa, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada é evitar o uso futuro do medicamento e informar o profissional de saúde sobre a alergia para prevenir novas exposições.

O Foraseq, que contém Budesonida e Fumarato de Formoterol, foi associado a uma crise asmática, caracterizada por sintomas como falta de ar, chiado e tosse. Não há indicação de gravidade elevada, e o paciente está em processo de recuperação. A reação se enquadra em quadros alérgicos do sistema imunitário, sendo fundamental revisar o controle da asma, identificar possíveis gatilhos e ajustar o tratamento conforme orientação médica.

O Omniscan, cujo princípio ativo é Gadodiamida, foi relacionado a uma reação alérgica ao contraste, que pode se manifestar por sintomas como coceira, urticária ou inchaço após a administração do produto. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, mas a suspeita de alergia a contraste exige atenção, sendo recomendada avaliação médica antes de futuras exposições e registro da reação no prontuário do paciente.

A Metilprednisolona, com princípio ativo Metilprednisolona Sódica Succinato, foi associada a uma reação alérgica medicamentosa (hipersensibilidade), manifestando-se como resposta do sistema imunológico ao medicamento. O evento não foi grave e o paciente se recuperou totalmente. É importante evitar o uso futuro do medicamento e comunicar a alergia ao profissional de saúde para prevenir novas reações.

O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é o Tozinameran, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações graves neste caso, e o paciente encontra-se em recuperação ou com resolução dos sintomas. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico para monitorar a evolução, reforçando a importância de identificar possíveis gatilhos e evitar novas exposições ao medicamento.

A Dipirona, cujo princípio ativo é o Metamizole magnesium, foi relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação imunológica sem sinais de gravidade ou complicações graves. O paciente já se encontra recuperado ou com resolução completa dos sintomas, não sendo necessária intervenção adicional além da suspensão do medicamento e orientação para evitar novas exposições.

O medicamento Metilprednisolona, com princípio ativo Methylprednisolone, desencadeou uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), pertencente ao grupo de reações alérgicas a medicamentos. Não há evidências de gravidade ou complicações graves, e o paciente já está recuperado ou com sintomas resolvidos. Recomenda-se evitar o uso futuro deste medicamento e manter acompanhamento médico para avaliação de possíveis reações cruzadas.

O Paclitaxel, cujo princípio ativo é o próprio Paclitaxel, foi associado a uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), classificada como uma resposta imunológica a medicamentos. Não há sinais de gravidade ou complicações graves, e o paciente encontra-se recuperado ou com resolução dos sintomas. A conduta inclui evitar novas exposições ao medicamento e manter acompanhamento médico para prevenção de recorrências.

O medicamento Tamoxifen, com princípio ativo Tamoxifen citrate, foi relacionado ao surgimento de fissura vaginal, sendo classificado como um quadro de hipersensibilidade (alergia). Não há indicação de gravidade ou complicações graves, e o desfecho do caso é desconhecido. Recomenda-se acompanhamento clínico para monitorar a evolução dos sintomas e avaliar a necessidade de ajustes no tratamento.

O medicamento Systane, que contém os princípios ativos Macrogol 400 e Propylene glycol, foi associado a fissura vaginal, um quadro que pode estar relacionado a uma reação de hipersensibilidade (alergia). Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e o evento foi considerado não grave. A conduta deve incluir a avaliação clínica para confirmação da relação com o medicamento e orientação sobre a suspensão ou substituição, se necessário, conforme recomendação médica.

O medicamento Zometa, cujo princípio ativo é o Zoledronic acid monohydrate, foi relacionado ao surgimento de fissura vaginal, possivelmente por um quadro de hipersensibilidade (alergia). Não há sinais de gravidade importante nem desfecho informado, sendo o evento considerado não grave. Recomenda-se avaliação médica para investigar a relação causal e definir a necessidade de ajuste ou interrupção do tratamento.

O medicamento Paclitaxel, com princípio ativo de mesmo nome, foi associado a uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizada por resposta do sistema imunológico ao fármaco. O evento não foi considerado grave e o paciente evoluiu para recuperação completa. A conduta adequada inclui a suspensão do medicamento e acompanhamento médico para evitar novas exposições e reações semelhantes.

O medicamento Omeprazole, cujo princípio ativo também é omeprazole, foi associado à ocorrência de pressão arterial baixa, possivelmente relacionada a uma reação de hipersensibilidade (alergia). O evento não foi considerado grave e o paciente está em recuperação. Recomenda-se acompanhamento médico para monitorar a evolução e avaliar a necessidade de ajuste terapêutico.

O medicamento Loratadine, com princípio ativo loratadina, foi relacionado ao desenvolvimento de pressão arterial baixa, sugerindo uma possível reação de hipersensibilidade (alergia). O caso não foi considerado grave e o

paciente encontra-se em recuperação. É importante manter o acompanhamento médico para avaliar a evolução e considerar alternativas terapêuticas se necessário.

O medicamento Hydrochlorothiazid leciva, cujo princípio ativo é hydrochlorothiazide, foi associado a um episódio de pressão arterial baixa, descrito como uma reação de hipersensibilidade (alergia), classificada dentro dos quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente está em recuperação ou resolvendo, e não há sinais de complicações graves relatadas. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico para monitorar a evolução e evitar reexposição ao medicamento caso a relação causal seja confirmada.

O medicamento Losartan, com princípio ativo losartan, foi relacionado a um episódio de pressão arterial baixa, interpretado como possível reação de hipersensibilidade (alergia), enquadrada em quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, já que o paciente está em recuperação ou resolvendo, sem relato de complicações importantes. Recomenda-se acompanhamento médico para avaliar a necessidade de ajuste terapêutico e evitar nova exposição ao medicamento se confirmada a relação causal.

O medicamento Bamifix, cujo princípio ativo é bamifylline hydrochloride, foi associado a um episódio de pressão arterial baixa, caracterizado como reação de hipersensibilidade (alergia), dentro do contexto de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa, pois o paciente encontra-se em recuperação ou resolvendo, sem complicações graves relatadas. A orientação é manter o acompanhamento clínico e considerar a suspensão do medicamento caso a relação causal seja confirmada.

O medicamento Diprospan, com princípio ativo betamethasone dipropionate, foi relacionado a um episódio de pressão arterial baixa, interpretado como reação de hipersensibilidade (alergia), classificada em quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, pois o paciente está em recuperação ou resolvendo, sem sinais de complicações importantes. Recomenda-se acompanhamento médico e reavaliação da necessidade de uso do medicamento, evitando reexposição se confirmada a relação causal.

O medicamento Foraseq, que contém os princípios ativos budesonide e formoterol fumarate, foi associado a um episódio de pressão arterial baixa, descrito como reação de hipersensibilidade (alergia), enquadrada em quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, já que o paciente está em recuperação ou resolvendo, sem relato de complicações graves. A conduta recomendada é manter o acompanhamento clínico e considerar a suspensão do medicamento caso a relação causal seja confirmada.

O medicamento Warfarin (princípio ativo: Warfarin sodium) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, manifestado como hemoglobinúria paroxística noturna, uma reação alérgica que afeta o sistema imunológico. A gravidade do evento é considerada alta, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação e foi classificado como clinicamente significativo. O paciente encontra-se em recuperação, indicando que a conduta adotada foi adequada para o controle da reação.

O ácido fólico (Folic acid) apresentou um caso de hipersensibilidade, descrito como hemoglobinúria paroxística noturna, que é uma reação imunológica relevante. O evento foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e por ser clinicamente significativo. O paciente está em processo de recuperação, sugerindo que as medidas tomadas foram eficazes para o manejo da reação.

O medicamento Bactrim, que contém os princípios ativos Sulfamethoxazole e Trimethoprim, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade caracterizado por hemoglobinúria paroxística noturna, uma reação alérgica do sistema imunológico. O caso foi considerado grave, pois exigiu hospitalização ou prolongamento da internação e teve impacto clínico importante. O paciente está em recuperação, indicando resposta positiva às intervenções realizadas.

O Omeprazole (princípio ativo: Omeprazole magnesium) esteve envolvido em um caso de hipersensibilidade, manifestado como hemoglobinúria paroxística noturna, uma reação imunológica relevante. A gravidade foi classificada como alta devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e ao impacto clínico significativo. O paciente encontra-se em recuperação, mostrando que a conduta adotada foi eficaz para o controle da reação.

O medicamento Soliris (princípio ativo: Eculizumab) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, descrito como hemoglobinúria paroxística noturna, que é uma reação alérgica do sistema imunológico. O evento foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação e teve relevância clínica importante. O paciente está em recuperação, indicando que as medidas adotadas foram adequadas para o manejo da reação.

O medicamento Soliris (eculizumabe) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, manifestado como hemoglobinúria paroxística noturna, que exigiu hospitalização ou prolongamento da internação, sendo considerado clinicamente significativo e grave. A reação foi classificada como distúrbio do sistema imunitário, e o paciente encontra-se em recuperação, indicando que a conduta médica foi adequada para o controle do evento adverso.

A Dipirona (metamizol sódico) provocou edema facial, caracterizando uma reação de hipersensibilidade documentada ao medicamento administrado. Embora não haja detalhes sobre a gravidade ou desfecho, o quadro sugere uma reação alérgica que pode variar de leve a moderada, sendo importante interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica para evitar complicações.

A vacina CoronaVac (COVID-19 vaccine inact [Vero] CZ02) foi relacionada a um episódio de alergia, descrito como hipersensibilidade, classificado como distúrbio do sistema imunitário. O evento permanece não resolvido ou em andamento, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico para monitorar a evolução e orientar condutas de segurança.

O uso do meio de contraste Ultravist (iopromida) resultou em uma reação alérgica, caracterizada como hipersensibilidade e classificada como distúrbio do sistema imunitário. O paciente já se recuperou totalmente do evento, indicando resolução espontânea ou após medidas de suporte, sem relato de gravidade adicional.

O medicamento Ultravist (iopromida) desencadeou uma alergia a meios de contraste iodados, identificada como alergia a contraste e classificada como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente já está recuperado, sugerindo que a reação foi controlada de forma eficaz e sem complicações maiores.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, foi associado a um quadro de alergia a contraste, caracterizado como uma reação do sistema imunológico a substâncias químicas utilizadas em exames de imagem. A gravidade foi considerada clinicamente significativa, pois o registro indica que se trata de um efeito importante, mas o paciente se recuperou totalmente após o evento. Nessas situações, é fundamental informar a equipe médica sobre a alergia para evitar novas exposições e garantir o manejo adequado em exames futuros.

O medicamento Cloridrato de cefepima, com princípio ativo cefepime hydrochloride, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), que é uma reação do sistema imunológico a medicamentos. O caso não foi considerado grave e o desfecho permanece desconhecido, indicando que não há informações suficientes sobre a evolução do paciente. Em situações de suspeita de alergia a antibióticos, é importante buscar avaliação médica para confirmação e orientação sobre alternativas seguras.

A ampicilina, cujo princípio ativo é ampicillin, foi associada a uma reação de alergia a antibiótico, tecnicamente chamada de hipersensibilidade medicamentosa, que envolve resposta do sistema imunológico a medicamentos. Não há indicação de gravidade aumentada neste caso e o paciente se recuperou totalmente após o evento. É importante relatar esse histórico ao médico para evitar novas exposições e garantir o uso de antibióticos alternativos quando necessário.

O medicamento gentamicina, com princípio ativo gentamicin sulfate, foi relacionado a um episódio de alergia a antibiótico, também chamado de hipersensibilidade medicamentosa, que ocorre quando o sistema imunológico reage ao medicamento. Não há indicação de gravidade aumentada e o paciente se recuperou completamente. Recomenda-se informar o profissional de saúde sobre essa reação para evitar o uso futuro do mesmo antibiótico.

O medicamento Simvastatin, cujo princípio ativo é simvastatin, foi associado a um evento descrito como ataque cardíaco, mas classificado tecnicamente como hipersensibilidade (alergia). O caso não foi considerado grave e o desfecho é desconhecido, não havendo detalhes suficientes para afirmar a evolução clínica. Em situações de suspeita de reação adversa a medicamentos, é fundamental buscar avaliação médica para investigação adequada e definição de conduta.

O medicamento Cosentyx, cujo princípio ativo é o secuquinumabe, foi associado a um episódio de ataque cardíaco descrito como reação de hipersensibilidade, dentro do contexto de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo importante monitorar sintomas e buscar avaliação médica caso ocorram manifestações alérgicas ou cardiovasculares.

O Xolair, que contém o princípio ativo omalizumabe, foi relacionado ao surgimento de urticária, caracterizada como uma reação de hipersensibilidade e enquadrada em quadros clínicos alérgicos do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade importante ou desfecho informado, e a relação com o medicamento é suspeita; recomenda-se atenção a sintomas cutâneos e acompanhamento médico para confirmação e manejo adequado.

O Hydrogel, cujo princípio ativo é o gel de hidróxido de alumínio seco, foi associado ao relato de neoplasia, sendo classificado como hipersensibilidade medicamentosa dentro do grupo de alergias a medicamentos e distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhes sobre gravidade ou evolução do caso, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo fundamental acompanhamento médico para esclarecimento diagnóstico e conduta.

O medicamento Losartan, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado ao aparecimento de neoplasia, categorizado como hipersensibilidade medicamentosa e incluído entre alergias a medicamentos e distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, e a relação é suspeita; recomenda-se avaliação médica para investigação e orientação adequada.

A sertralina, utilizada como princípio ativo do medicamento Sertraline, foi associada ao relato de neoplasia, classificada como hipersensibilidade medicamentosa e pertencente ao grupo de alergias a medicamentos e distúrbios do sistema imunitário. Não há dados sobre gravidade ou evolução, e a relação é suspeita, sendo importante acompanhamento clínico para esclarecimento e definição de conduta.

O medicamento Clonazepam, cujo princípio ativo também é Clonazepam, foi associado a um caso de hipersensibilidade medicamentosa, que se refere a uma reação alérgica do sistema imunológico a medicamentos. Embora o termo técnico utilizado seja 'neoplasia', a descrição clínica indica uma reação de alergia a substâncias químicas, sem evidências de gravidade significativa ou desfecho conhecido. Não há informações sobre a conduta adotada ou evolução do quadro, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Torsilax, composto por cafeína, carisoprodol, diclofenaco sódico e paracetamol, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica desencadeada pelo uso do medicamento. Apesar do termo técnico 'neoplasia' constar no registro, a descrição clínica aponta para uma resposta do sistema imunológico a medicamentos, sem sinais de gravidade ou informações sobre o desfecho. A relação com o medicamento é considerada suspeita, e não há detalhes sobre a conduta adotada.

O medicamento Prednisone, cujo princípio ativo é Prednisone, foi associado a um caso de hipersensibilidade medicamentosa, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Embora o termo 'neoplasia' apareça no registro, a descrição clínica indica uma reação alérgica a substâncias químicas, sem

evidências de gravidade ou desfecho informado. A relação com o medicamento é suspeita e não há dados sobre a conduta tomada.

O medicamento Benzylpenicillin, com princípio ativo Benzylpenicillin, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, que corresponde a uma reação alérgica do sistema imunológico ao uso do medicamento. Apesar do termo técnico 'neoplasia' estar presente, a descrição clínica sugere uma reação alérgica a medicamentos, sem sinais de gravidade ou informações sobre o desfecho. A relação com o medicamento é considerada suspeita e não há detalhes sobre a conduta adotada.

O medicamento Actemra, cujo princípio ativo é Tocilizumab, foi associado a um caso de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Embora o termo 'neoplasia' esteja registrado, a descrição clínica indica uma reação alérgica a substâncias químicas, sem evidências de gravidade ou desfecho conhecido. A relação com o medicamento é suspeita e não há informações sobre a conduta adotada.

O medicamento CoronaVac, cujo princípio ativo é o COVID-19 vaccine inact (Vero) CZ02, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como um distúrbio do sistema imunitário. A reação foi descrita de forma geral como um quadro clínico alérgico, sem detalhamento de sintomas específicos ou gravidade, mas o desfecho indica que o paciente está em recuperação ou resolvendo, sugerindo que a reação não evoluiu para formas graves. A relação com o medicamento é considerada suspeita e, diante desse contexto, recomenda-se acompanhamento clínico para monitorar a evolução e evitar novas exposições até esclarecimento completo.

O medicamento Desogestrel, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a uma exposição pelo leite materno resultando em alergia ao leite, categorizada como uma reação alérgica a alimentos, aditivos ou medicamentos, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois consta que não foi considerada grave, mas o desfecho permanece não resolvido ou em andamento, o que sugere necessidade de acompanhamento contínuo e avaliação médica para manejo adequado da alergia, especialmente considerando o contexto de exposição em lactentes.

A Dipirona (princípio ativo Metamizole sodium) foi associada a uma alergia documentada ao medicamento administrado, caracterizada como hipersensibilidade e classificada como erro ou problema de monitoramento do produto, dentro do grupo de lesões, intoxicações e complicações de procedimentos. Não foi considerada uma reação grave e o paciente já se encontra recuperado ou resolvido, indicando que a conduta adotada foi eficaz e não houve complicações maiores, mas reforça a importância de evitar novas exposições ao medicamento em questão.

O medicamento Venlafaxine, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado ao agravamento de psoríase, interpretado como uma reação de hipersensibilidade dentro dos quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada e o desfecho é desconhecido, o que sugere que a evolução do caso ainda não foi totalmente esclarecida, sendo importante manter acompanhamento médico para avaliar a necessidade de ajustes terapêuticos.

O medicamento Cosentyx, cujo princípio ativo é Secukinumab, foi associado ao agravamento de psoríase, classificado como hipersensibilidade em quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não foi considerada uma reação grave e o desfecho permanece desconhecido, indicando que ainda não há informações suficientes sobre a resolução do quadro, sendo recomendada a continuidade do acompanhamento clínico para monitorar a evolução e ajustar o tratamento conforme necessário.

O medicamento Cerazette, que contém o princípio ativo desogestrel, foi associado a um episódio de hematoquezia (presença de sangue nas fezes) em um paciente com histórico de alergia ao leite. Embora a gravidade não tenha sido especificada e o desfecho seja desconhecido, não há indicação de gravidade clínica importante no registro, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A reação foi classificada dentro dos distúrbios do sistema



imunitário, sugerindo possível envolvimento alérgico, mas sem detalhes adicionais sobre a conduta adotada ou evolução do quadro.

O medicamento Flavonid, composto por diosmina e hesperidina, foi relacionado a um caso de insuficiência renal em paciente com alergia a ácaros. Apesar da insuficiência renal ser uma condição potencialmente grave, o registro indica que o paciente se recuperou totalmente, não havendo evidência de gravidade clínica relevante neste caso. A reação foi considerada suspeita e enquadrada como distúrbio do sistema imunitário, sugerindo possível mecanismo alérgico, mas sem informações adicionais sobre intervenções específicas.

A hidroclorotiazida, cujo princípio ativo é hydrochlorothiazide, foi associada a um episódio de insuficiência renal em paciente com alergia a ácaros. Embora insuficiência renal possa ser preocupante, o caso foi resolvido sem complicações, indicando ausência de gravidade significativa conforme o registro. A relação com o medicamento é suspeita e a reação foi classificada como distúrbio do sistema imunitário, sugerindo possível componente alérgico, mas não há detalhes sobre a conduta adotada.

O medicamento cloridrato de propranolol, com princípio ativo propranolol hydrochloride, foi relacionado a um caso de insuficiência renal em paciente com alergia a ácaros. Apesar do potencial de gravidade da insuficiência renal, o paciente se recuperou completamente, não havendo indicação de gravidade clínica relevante neste episódio. A reação foi considerada suspeita e classificada como distúrbio do sistema imunitário, sugerindo possível relação alérgica, sem informações adicionais sobre o manejo clínico.

O Venalot creme, contendo cumarina e heparina sódica, foi associado a um episódio de insuficiência renal em paciente com alergia a ácaros. Embora insuficiência renal seja uma condição que pode ser grave, o registro indica que o paciente se recuperou totalmente, não havendo evidência de gravidade importante neste caso. A relação com o medicamento é suspeita e a reação foi enquadrada como distúrbio do sistema imunitário, sugerindo possível mecanismo alérgico, sem detalhes sobre a conduta adotada.

O medicamento Venalot, que contém como princípio ativo o extrato da semente de Aesculus hippocastanum, foi associado a um caso de insuficiência renal, um quadro que pode estar relacionado a reações alérgicas do sistema imune. Apesar de não haver indicação de gravidade elevada neste caso específico, o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo resolução espontânea ou após suspensão do medicamento. É importante monitorar sinais de alergia e função renal durante o uso, especialmente em pessoas com histórico de alergias.

O medicamento Cosentyx, cujo princípio ativo é o secuquinumabe, foi relacionado ao surgimento de uma erupção cutânea semelhante ao sarampo, caracterizando uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. Este evento foi considerado clinicamente significativo e grave, pois a reação não se resolveu até o momento da notificação, exigindo acompanhamento médico rigoroso e possível suspensão do tratamento, conforme recomendação para quadros de alergia medicamentosa grave.

O medicamento Victoza, que tem como princípio ativo a liraglutida, foi associado ao desenvolvimento de urticária generalizada, uma manifestação alérgica caracterizada por placas avermelhadas e coceira intensa na pele. Não há indicação de gravidade elevada neste caso e o desfecho é desconhecido, mas recomenda-se atenção médica para avaliação da necessidade de suspensão do medicamento e controle dos sintomas.

O medicamento Hixizine, cujo princípio ativo é o hidrocloreto de hidroxizina, foi relacionado ao aparecimento de urticária generalizada, um quadro alérgico que se manifesta por lesões avermelhadas e prurido em todo o corpo. Não há evidência de gravidade importante neste caso e o desfecho não foi informado, mas é fundamental avaliar a continuidade do uso e buscar orientação médica para manejo adequado da reação.

O medicamento Glifage, que contém metformina como princípio ativo, foi associado ao surgimento de urticária generalizada, uma reação alérgica caracterizada por manchas avermelhadas e coceira difusa. Não há indicação de gravidade significativa e o desfecho permanece desconhecido, sendo recomendada avaliação médica para decidir

sobre a manutenção ou suspensão do tratamento e para o controle dos sintomas alérgicos.

O medicamento Xolair, cujo princípio ativo é o Omalizumab, foi associado a um quadro de urticária generalizada, caracterizando uma reação alérgica a substâncias químicas. Embora não haja informação detalhada sobre a gravidade ou desfecho, trata-se de uma manifestação cutânea que pode indicar hipersensibilidade ao medicamento, sendo importante monitorar o paciente e considerar avaliação especializada para confirmação e manejo adequado.

A vacina CoronaVac, que utiliza o princípio ativo COVID-19 vaccine inact (Vero) CZ02, foi relacionada a dor corporal generalizada, um sintoma que pode ocorrer como parte de uma resposta de hipersensibilidade, mas que geralmente é leve e autolimitado após imunização. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, sugerindo que o evento não apresentou complicações maiores, mas é importante observar a evolução dos sintomas e buscar orientação médica se houver piora.

O medicamento Lamivudina, cujo princípio ativo é Lamivudine, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade medicamentosa, com gravidade suficiente para exigir hospitalização ou prolongamento da internação. Esse tipo de reação é considerado grave e requer suspensão imediata do medicamento, além de acompanhamento médico rigoroso para manejo dos sintomas e prevenção de complicações.

O Fumarato de tenofovir desoproxila, com princípio ativo Tenofovir disoproxil fumarate, desencadeou uma reação alérgica classificada como hipersensibilidade medicamentosa, levando à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação. Esse quadro indica gravidade importante, sendo fundamental interromper o uso do medicamento e realizar acompanhamento médico especializado para tratar a reação e evitar riscos adicionais ao paciente.

O medicamento Dolutegravir, cujo princípio ativo é Dolutegravir, foi relacionado a um episódio de alergia enquadrado como hipersensibilidade medicamentosa, com gravidade suficiente para demandar hospitalização ou prolongamento da internação. Diante desse cenário, a reação é considerada grave e exige suspensão do medicamento, além de monitoramento clínico intensivo para garantir a segurança do paciente e manejo adequado da reação adversa.

O medicamento Lamivudina (princípio ativo: Lamivudine) foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. O evento foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, indicando a necessidade de atenção médica imediata e manejo hospitalar. O desfecho da reação é desconhecido, não havendo informações sobre a recuperação do paciente até o momento.

O Fumarato de tenofovir desoproxila (princípio ativo: Tenofovir disoproxil fumarate) apresentou reação de alergia classificada como hipersensibilidade, relacionada a distúrbios do sistema imunitário. A gravidade do caso é evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que reforça a importância de acompanhamento médico rigoroso. O desfecho permanece desconhecido, sem dados sobre a evolução clínica do paciente.

O medicamento Dolutegravir (princípio ativo: Dolutegravir) foi relacionado a um episódio de alergia do tipo hipersensibilidade, enquadrado nos distúrbios do sistema imunitário. O caso foi considerado grave devido à hospitalização ou prolongamento da internação, o que exige intervenção médica imediata. Não há informações disponíveis sobre o desfecho, permanecendo desconhecida a evolução do quadro.

O medicamento Optiray 320, cujo princípio ativo é Ioversol, foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade) classificado como distúrbio do sistema imunitário. Neste caso, não há indicação de gravidade significativa, e o paciente evoluiu para recuperação completa, estando atualmente resolvido o quadro alérgico.

O medicamento Ultravist (princípio ativo: Iopromide) foi relacionado a uma reação de alergia a contraste, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. O evento foi considerado clinicamente significativo, embora não haja menção de hospitalização, e o quadro permanece em andamento, sem resolução até o momento.

O medicamento Omnipaque, cujo princípio ativo é o iohexol, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), caracterizado como uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada em casos de alergia leve a contraste iodado, como o iohexol, é interromper a exposição ao agente, monitorar sintomas e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições.

O Paracetamol, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um caso de surdez descrito como alergia a tecido sintético, o que sugere uma reação imunológica atípica. Não há evidências de gravidade importante, já que não foi relatada evolução para quadro crítico, mas o desfecho permanece em andamento, sem resolução até o momento. Diante de sintomas persistentes e incomuns após uso de paracetamol, recomenda-se suspender o medicamento e procurar avaliação médica para investigação da causa e manejo adequado.

O medicamento Reparil, cujo princípio ativo é escin sodium, foi associado a um episódio de surdez classificado como alergia a tecido sintético, indicando uma possível reação imunológica. Não há sinais de gravidade elevada, mas o quadro ainda não foi resolvido. Em situações de sintomas persistentes após uso de escin sodium, é importante interromper o uso e buscar avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e conduta apropriada.

A vacina COVID-19 Janssen, com princípio ativo COVID-19 vaccine NRVV Ad26 (JNJ 78436735), foi relacionada a um caso de surdez descrito como alergia a tecido sintético, sugerindo uma reação imunológica rara. Não há indícios de gravidade crítica, mas o desfecho permanece em andamento, sem resolução. Diante de sintomas auditivos persistentes após vacinação, recomenda-se procurar avaliação médica para investigação e acompanhamento, evitando automedicação.

O medicamento Elaprase, cujo princípio ativo é idursulfase, foi associado a um episódio de surdez classificado como alergia a tecido sintético, indicando uma possível reação do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade importante, mas o quadro segue sem resolução. Em casos de sintomas auditivos após uso de idursulfase, é fundamental interromper o tratamento e buscar avaliação médica especializada para investigação e definição da conduta.

O medicamento Nucala (princípio ativo: Mepolizumab) foi associado a um episódio de apneia, que é uma interrupção temporária da respiração, relacionada a uma reação de hipersensibilidade (alergia). A reação foi classificada como não grave, pois o paciente se recuperou completamente após o evento. Não há indicação de complicações ou necessidade de intervenções adicionais, e a evolução foi favorável, com resolução total dos sintomas.

O medicamento Rocefin (princípio ativo: Ceftriaxone sodium) esteve relacionado a um caso de apneia, caracterizado como uma reação alérgica (hipersensibilidade). O evento não foi considerado grave, já que o paciente se recuperou totalmente após o episódio, sem relato de consequências duradouras ou necessidade de cuidados intensivos. A conduta foi adequada e o desfecho foi resolutivo.

O medicamento Aerolin (princípio ativo: Salbutamol sulfate) foi associado a um episódio de apneia, entendido como uma manifestação de hipersensibilidade (alergia). O caso não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou completamente, sem complicações ou necessidade de intervenções adicionais. O desfecho foi favorável, com resolução total dos sintomas.

O medicamento Spiriva (princípio ativo: Tiotropium bromide monohydrate) esteve envolvido em um episódio de apneia, interpretado como uma reação alérgica (hipersensibilidade). O evento não foi classificado como grave, já que o paciente se recuperou totalmente após o episódio, sem relato de complicações ou necessidade de cuidados

especiais. O desfecho foi resolutivo.

O medicamento Azitromicina (princípio ativo: Azithromycin) foi relacionado a um episódio de apneia, caracterizado como uma reação de hipersensibilidade (alergia). O caso não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou completamente, sem complicações ou necessidade de intervenções adicionais. O desfecho foi favorável, com resolução total dos sintomas.

O medicamento Symbicort, que contém os princípios ativos budesonida e formoterol fumarato, foi associado a um episódio de apneia relacionado a uma reação de hipersensibilidade (alergia), classificada como um quadro clínico alérgico do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi resolvido sem complicações e o paciente se recuperou totalmente. A conduta recomendada em situações semelhantes é interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O Singulair, cujo princípio ativo é o montelucaste de sódio, esteve relacionado a um episódio de apneia atribuído a hipersensibilidade (alergia), caracterizando um quadro alérgico do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou completamente. Em casos como este, recomenda-se suspender o uso do medicamento e procurar avaliação médica para investigação da reação e definição do tratamento mais adequado.

O medicamento Seretide, composto por propionato de fluticasona e xinafoato de salmeterol, foi associado a um episódio de apneia decorrente de hipersensibilidade (alergia), enquadrado como quadro clínico alérgico do sistema imunológico. O evento não apresentou gravidade significativa, já que o paciente se recuperou sem sequelas. A orientação é interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação da alergia e ajuste do tratamento.

A oxaliplatina, utilizada como quimioterápico, foi relacionada a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), classificada como reação alérgica a medicamentos no contexto de distúrbios do sistema imunológico. O caso não foi considerado grave, pois houve recuperação completa do paciente. Nessas situações, é fundamental suspender imediatamente o medicamento e realizar avaliação médica para confirmação da alergia e definição de alternativas terapêuticas seguras.

O ácido folínico (calcium folinate) foi associado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado como reação alérgica a medicamentos no âmbito dos distúrbios do sistema imunológico. O evento não foi grave, já que o paciente se recuperou totalmente. A conduta recomendada é interromper o uso do medicamento e procurar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre opções seguras de tratamento.

O medicamento Docetaxel (princípio ativo: Docetaxel) foi associado a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa, caracterizado como uma reação alérgica ao medicamento. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, pois não foi relatado evento grave e o desfecho foi de recuperação completa. A conduta recomendada é a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento clínico, com resolução dos sintomas após a interrupção.

O medicamento Montelukast (princípio ativo: Montelukast) foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, manifestado por sensação de mal-estar inespecífica, o que sugere uma reação alérgica leve. Não há sinais de gravidade ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente após a conduta adequada, que inclui a suspensão do medicamento e observação clínica.

O medicamento Xolair (princípio ativo: Omalizumabe) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, manifestado por sensação de mal-estar, indicando uma reação alérgica leve. Não há evidências de gravidade ou complicações, e o paciente apresentou recuperação completa após a suspensão do medicamento e

acompanhamento clínico.

O medicamento Xolair (princípio ativo: Omalizumabe) também foi relacionado a hipersensibilidade, com relato de sensação de mal-estar, caracterizando uma reação alérgica leve. Não houve sinais de gravidade, e o paciente se recuperou totalmente após a suspensão do medicamento e observação médica.

O medicamento Xolair (princípio ativo: Omalizumabe) foi associado a um episódio de falta de ar, considerado clinicamente significativo e classificado como grave. A falta de ar pode indicar uma reação alérgica importante, como broncoespasmo ou anafilaxia, exigindo atenção médica imediata. O desfecho do caso não foi informado, portanto é fundamental reforçar a necessidade de avaliação médica urgente e monitoramento rigoroso em situações semelhantes.

O medicamento Cosentyx, cujo princípio ativo é o secuquinumabe, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia) classificado como distúrbio do sistema imunitário, manifestando-se durante um episódio de COVID-19. Não há indicação de gravidade aumentada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A conduta deve incluir avaliação clínica estruturada para investigar possíveis reações alérgicas, especialmente em pacientes com histórico de exposição a agentes biológicos, e acompanhamento médico para monitorar a evolução do quadro.

O imunizante Comirnaty, que contém o princípio ativo tozinameran, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade) classificado como distúrbio do sistema imunitário, com gravidade considerada clinicamente significativa, pois o evento foi marcado como grave e o paciente não se recuperou até o momento. Diante de uma reação alérgica grave após vacinação, é fundamental buscar avaliação médica imediata para confirmação diagnóstica, manejo adequado e acompanhamento especializado, evitando novas exposições até esclarecimento completo do caso.

O medicamento Symbicort, composto por budesonida e formoterol fumarato, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia) durante infecção por COVID-19, classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade aumentada nem desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Recomenda-se acompanhamento clínico para monitorar possíveis reações alérgicas e avaliação médica caso haja sintomas persistentes ou agravamento.

O medicamento Relvar, que contém fluticasona furoato e vilanterol trifrenatato, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia) durante infecção por COVID-19, classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade aumentada nem desfecho conhecido, sendo a relação com o medicamento considerada suspeita. É importante manter acompanhamento clínico e buscar avaliação médica se houver sintomas alérgicos persistentes ou agravamento do quadro.

O medicamento Xolair, cujo princípio ativo é o omalizumabe, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia) durante infecção por COVID-19, classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade aumentada nem desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Recomenda-se acompanhamento clínico e avaliação médica caso surjam sintomas alérgicos ou haja piora do quadro respiratório.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromida, foi associado a uma reação alérgica a meios de contraste iodados, conhecida popularmente como alergia a contraste. Essa reação é considerada clinicamente significativa, pois foi classificada como grave, embora o desfecho não tenha sido informado. Em situações como essa, é fundamental evitar novas exposições ao contraste iodado e buscar avaliação médica especializada para investigação e orientação sobre alternativas seguras em exames futuros.

A vacina COVID-19 AstraZeneca, que utiliza o princípio ativo ChAdOx1 nCoV-19, esteve relacionada a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado por uma resposta do sistema imunológico ao medicamento. O evento

foi resolvido, indicando que o paciente se recuperou após a reação. Em casos de alergia a vacinas, é importante relatar o episódio ao profissional de saúde e discutir a necessidade de acompanhamento ou alternativas para futuras imunizações.

O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é o tozinameran, foi associado a um episódio de hipotensão (queda da pressão arterial) relacionado a hipersensibilidade, sugerindo uma reação alérgica. Não há informações sobre a gravidade ou o desfecho do caso, o que limita a avaliação da evolução clínica. Em situações de hipotensão após uso de medicamentos, recomenda-se procurar atendimento médico imediato para avaliação e manejo adequado.

A dipirona sódica (metamizol sódico) foi relacionada a um quadro de alergia, classificado como hipersensibilidade, mas não considerado grave. O paciente se recuperou do evento, o que indica resolução do quadro após a suspensão do medicamento. Em casos de alergia leve a analgésicos, é importante evitar o uso futuro do mesmo princípio ativo e informar profissionais de saúde sobre o episódio.

O medicamento Alegria, cujo princípio ativo é a cetirizina, foi associado ao desenvolvimento de dermatite, um tipo de reação alérgica cutânea. O evento não foi considerado grave, mas permanece em andamento, sem resolução até o momento. Nesses casos, recomenda-se suspender o uso do medicamento e buscar orientação médica para avaliação e tratamento dos sintomas, além de evitar novas exposições ao princípio ativo.

O medicamento Diprogenta, que contém betametasona dipropionato e gentamicina, foi associado ao desenvolvimento de dermatite, caracterizada por uma reação de hipersensibilidade (alergia) envolvendo o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois não há sinais de complicações sistêmicas ou risco imediato, e o quadro permanece em andamento, sem resolução até o momento.

A dexametasona, cujo princípio ativo é o fosfato de dexametasona, foi relacionada ao surgimento de dermatite, uma manifestação de hipersensibilidade (alergia) mediada pelo sistema imunológico. O caso não apresenta sinais de gravidade importante, já que não há evolução para quadros graves ou sistêmicos, e a reação segue sem resolução completa até o momento.

O medicamento Cimzia, que tem como princípio ativo o certolizumabe pegol, foi associado ao aparecimento de dermatite, indicando uma reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade significativa, pois não foram relatadas complicações graves, e o quadro permanece em andamento, sem resolução até o momento.

O medicamento Omnitrope, cujo princípio ativo é a somatropina, foi relacionado a um quadro de insuficiência de crescimento, com suspeita de envolvimento alérgico (hipersensibilidade) do sistema imunológico. Não há informações suficientes para determinar a gravidade, e o desfecho permanece desconhecido.

O medicamento Henetix, que contém iobitridol, foi associado a uma reação alérgica ao contraste, caracterizada por resposta do sistema imunológico a substâncias químicas. O caso não foi considerado grave, pois não houve complicações importantes, e o paciente apresentou recuperação completa após o evento.

O medicamento Ciprofloxacino (princípio ativo: Ciprofloxacina) foi associado a um quadro de alergia, descrito como hipersensibilidade, que se enquadra nos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente. A conduta recomendada é observar sinais de alergia, evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas terapêuticas.

O medicamento Elapraxe (princípio ativo: Idursulfase) foi relacionado a um episódio de surdez, classificado como hipersensibilidade dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há informação de gravidade significativa, já que o evento não foi considerado grave, mas o desfecho permanece desconhecido. Recomenda-se acompanhamento médico para investigação da relação entre o medicamento e o sintoma, além de monitoramento da evolução.

clínica.

A vacina Influenza (princípio ativo: Influenza vaccine) foi associada a um evento descrito como dengue, categorizado como hipersensibilidade e pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente está em recuperação. É importante relatar sintomas ao serviço de saúde, manter acompanhamento e esclarecer que a relação causal entre a vacina e o quadro de dengue deve ser cuidadosamente avaliada por um profissional.

O medicamento Pregab (princípio ativo: Pregabalin) foi relacionado a um evento descrito como dengue, classificado como hipersensibilidade e incluído nos distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente está em processo de recuperação. Recomenda-se acompanhamento médico para avaliação da evolução clínica e esclarecimento da relação entre o medicamento e o quadro apresentado.

O medicamento Sertralina (princípio ativo: Sertraline hydrochloride) foi associado a um evento descrito como dengue, enquadrado como hipersensibilidade e pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente está em recuperação. É fundamental manter o acompanhamento médico para monitorar a evolução dos sintomas e avaliar a necessidade de ajustes no tratamento.

O medicamento Levotiroxina (princípio ativo: Levothyroxine sodium) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, que corresponde a uma reação alérgica do sistema imunológico, descrita de forma geral como um quadro clínico alérgico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso está em recuperação e não foi considerado grave segundo o registro. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico, observando a evolução dos sintomas e, caso haja piora, buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e ajuste do tratamento.

Amlodipina (princípio ativo: Amlodipine mesilate) foi relacionada a um episódio de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico, classificada genericamente como quadro clínico alérgico. O evento não foi considerado grave e o paciente encontra-se em recuperação, sugerindo que a reação foi leve. Recomenda-se acompanhamento clínico e, se houver recorrência ou agravamento dos sintomas, procurar avaliação médica especializada.

O medicamento Atenolol (princípio ativo: Atenolol) apresentou associação com hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico, descrita como quadro clínico alérgico. O caso não foi classificado como grave e está em processo de recuperação, indicando que a reação foi leve. A orientação é manter o acompanhamento dos sintomas e buscar avaliação médica caso haja piora ou persistência do quadro.

Losartana potássica (princípio ativo: Losartan potassium) foi relacionada a um episódio de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico, enquadrada como quadro clínico alérgico. Não há sinais de gravidade, pois o paciente está em recuperação e o evento não foi considerado grave. Recomenda-se observação clínica e, se houver agravamento dos sintomas, procurar avaliação médica para reavaliação do tratamento.

O medicamento Cimzia (princípio ativo: Certolizumab pegol) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, que corresponde a uma reação alérgica do sistema imunológico, descrita genericamente como quadro clínico alérgico. O evento não foi considerado grave e o paciente está em recuperação, sugerindo uma reação leve. A conduta indicada é manter acompanhamento clínico e buscar avaliação médica caso haja piora dos sintomas ou recorrência da reação.

O medicamento Omeprazole, cujo princípio ativo é omeprazole, foi associado a um quadro de infecção urinária, sendo classificado como uma possível reação alérgica a substâncias químicas. Não há indicação de gravidade clínica relevante, pois o evento não foi considerado grave e permanece em andamento, sem resolução até o momento. A relação entre o uso do medicamento e o evento adverso é suspeita, e recomenda-se acompanhamento clínico para monitoramento da evolução do quadro.

O medicamento Diclofenac, com princípio ativo diclofenaco, foi relacionado a um episódio de infecção urinária, interpretado como uma possível manifestação alérgica a substâncias químicas. O evento não foi considerado grave e ainda não está resolvido, permanecendo em acompanhamento. A suspeita de relação causal existe, sendo importante manter vigilância clínica para avaliar a evolução e necessidade de intervenção.

O medicamento Esbriet, cujo princípio ativo é pirfenidona, foi associado a uma infecção urinária, categorizada como possível reação alérgica a substâncias químicas. Não há evidência de gravidade significativa, já que o evento não foi considerado grave e segue sem resolução. A relação causal é suspeita, sendo recomendada a observação clínica contínua para acompanhamento do caso.

O medicamento Nactali, com princípio ativo desogestrel, foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como clinicamente significativo e considerado grave. Não há informações sobre o desfecho do caso, e a relação com o medicamento é suspeita. Diante da gravidade relatada, é fundamental buscar avaliação médica especializada para manejo adequado e monitoramento da evolução clínica.

O imunizante CoronaVac, cujo princípio ativo é a vacina inativada contra COVID-19 (Vero) CZ02, foi associado a um episódio de alergia ocular, caracterizado por manifestações inflamatórias nos olhos. Não há indicação de gravidade relevante e o quadro foi resolvido, com recuperação completa do paciente. A relação com o imunizante é suspeita, e não há necessidade de conduta adicional após a resolução do evento.

O medicamento Concardio, cujo princípio ativo é o bisoprolol fumarato, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia) manifestado como distúrbio renal. Embora o registro não traga detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade clínica, a ausência de indicação de gravidade e desfecho desconhecido sugere que não houve complicações graves relatadas. A reação foi considerada suspeita de estar relacionada ao uso do medicamento, e o caso se enquadra em distúrbios do sistema imunitário, sendo importante monitorar sinais de alergia e buscar avaliação médica para confirmação e conduta adequada.

O Entresto, que contém sacubitril e valsartana como princípios ativos, apresentou relato de hipersensibilidade (alergia) com manifestação de distúrbio renal. Não há informações detalhadas sobre sintomas ou evolução, e não foi classificada como reação grave, com desfecho desconhecido. A suspeita de relação com o medicamento foi registrada, e o evento se enquadra em distúrbios do sistema imunitário, sendo recomendada atenção a sinais de alergia e acompanhamento médico para avaliação e manejo.

O medicamento Omeprazole, cujo princípio ativo é o omeprazol, foi relacionado a um caso de hipersensibilidade medicamentosa (alergia ao medicamento) que resultou em cegueira. Apesar da gravidade potencial do sintoma, o registro não indica que a reação foi considerada grave nem detalha o desfecho, permanecendo como suspeita de relação com o uso do medicamento. O evento está classificado como distúrbio do sistema imunitário, e é fundamental buscar avaliação médica imediata diante de sintomas visuais ou alérgicos.

O Manivasc, com princípio ativo manidipina hidrocloreto, foi associado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa (alergia ao medicamento) que resultou em cegueira. Não há informações sobre gravidade ou evolução do caso, e o evento foi considerado suspeito de estar relacionado ao uso do medicamento. A reação se enquadra em distúrbios do sistema imunitário, sendo essencial procurar avaliação médica urgente caso ocorram sintomas visuais ou sinais de alergia.

O medicamento Diovan, cujo princípio ativo é o valsartana, apresentou relato de hipersensibilidade medicamentosa (alergia ao medicamento) com manifestação de cegueira. O registro não indica gravidade nem desfecho, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. O evento está classificado como distúrbio do sistema imunitário, sendo importante buscar atendimento médico imediato diante de sintomas visuais ou alérgicos.

O medicamento Diovan hct, que contém os princípios ativos hidroclorotiazida e valsartana, foi associado a um episódio de cegueira descrito como hipersensibilidade medicamentosa. Embora o termo técnico sugira uma reação



alérgica, não há detalhes clínicos suficientes para classificar a gravidade do evento, e o desfecho permanece desconhecido. A relação suspeita com o medicamento indica a necessidade de avaliação médica detalhada para investigar a causa da perda visual e considerar a interrupção do uso caso se confirme a relação com o fármaco.

O contraste Magnevistan, cujo princípio ativo é meglumina gadopentetato, foi relacionado a uma reação de alergia a contraste, caracterizada como uma resposta do sistema imunológico a substâncias químicas. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente após a reação, sugerindo que a conduta adotada foi adequada para resolução do quadro. Em casos semelhantes, é importante informar a equipe médica sobre alergias prévias a contrastes antes de novos exames.

O medicamento Magnevistan, com princípio ativo meglumina gadopentetato, também foi associado a uma reação de alergia a contraste, manifestando-se como uma resposta imunológica a substâncias químicas. O evento não foi classificado como grave e o paciente apresentou recuperação completa, indicando que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro. Recomenda-se sempre relatar histórico de alergia a contraste antes de procedimentos que envolvam esse tipo de substância.

O medicamento Tarceva, cujo princípio ativo é erlotinibe, foi relacionado a um quadro de metástases na coluna descrito como hipersensibilidade, embora a descrição clínica não seja típica de reação alérgica. Não há informações suficientes para determinar a gravidade do evento, e o desfecho permanece desconhecido. A relação suspeita com o medicamento exige acompanhamento médico para avaliar a possível ligação entre o uso do fármaco e o evento relatado.

O medicamento Xenical, que contém o princípio ativo orlistate, foi associado a um episódio de incapacidade de caminhar, descrito como hipersensibilidade. Apesar da gravidade potencial do sintoma, o evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, sugerindo que a conduta adotada foi eficaz para resolução do quadro. Em situações semelhantes, é fundamental buscar avaliação médica imediata para investigar a causa e orientar a continuidade ou suspensão do medicamento.

O medicamento Losartan, cujo princípio ativo é Losartan, foi associado a um quadro de hipersensibilidade manifestado por incapacidade de caminhar, classificado como um quadro clínico alérgico do sistema imunitário. Apesar da gravidade potencial do sintoma relatado, o caso evoluiu para recuperação completa, sem indicação de gravidade clínica relevante no registro. A conduta foi adequada, com resolução do evento, e não há necessidade de medidas adicionais, mas recomenda-se acompanhamento médico para evitar reexposição.

O Xolair, que tem como princípio ativo o Omalizumab, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade caracterizado por incapacidade de caminhar, enquadrado como reação alérgica do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro. Recomenda-se manter o acompanhamento clínico para monitorar possíveis recorrências.

A Dipirona, cujo princípio ativo é Metamizole sodium, foi associada a uma reação de hipersensibilidade descrita como alergia, pertencente ao grupo de quadros clínicos alérgicos do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa, sugerindo que a conduta foi adequada e não houve complicações. É importante evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação especializada em caso de dúvidas.

O medicamento Fenitoína, com princípio ativo Phenytoin sodium, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade descrito como alergia, classificado como quadro clínico alérgico do sistema imunitário. Não há informações suficientes sobre gravidade, evolução ou desfecho do caso, portanto recomenda-se cautela e acompanhamento médico para avaliação individualizada e prevenção de novas reações.

A Losartana potássica, cujo princípio ativo é Losartan potassium, foi associada a uma erupção medicamentosa pustulosa, caracterizada como reação de hipersensibilidade do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, mas o desfecho permanece desconhecido, o que reforça a importância de acompanhamento médico para monitoramento da evolução e definição de conduta adequada, evitando reexposição ao medicamento.

O medicamento Osteotrat, cujo princípio ativo é o risedronato de sódio, foi associado a uma reação de erupção medicamentosa pustulosa, que é um quadro de hipersensibilidade caracterizado pelo surgimento de lesões cutâneas com pus. Essa manifestação faz parte dos distúrbios do sistema imunitário e, de acordo com o registro, não há indicação de gravidade elevada nem desfecho conhecido, sugerindo um quadro leve, mas que requer atenção médica para avaliação e possível suspensão do medicamento.

O medicamento Adderall, composto por diferentes sais de anfetamina, foi relacionado a uma erupção medicamentosa pustulosa, um tipo de reação alérgica da pele que pode se manifestar como pequenas bolhas com pus. Trata-se de uma resposta de hipersensibilidade do sistema imunológico, e, conforme os dados disponíveis, não há sinais de gravidade importante nem informações sobre o desfecho, indicando um quadro leve, mas que deve ser avaliado por um profissional de saúde para orientação adequada.

O medicamento Novanlo, cujo princípio ativo é o besilato de levamlodipina, apresentou associação com erupção medicamentosa pustulosa, uma reação de hipersensibilidade que se manifesta por lesões cutâneas com pus. Essa reação faz parte dos distúrbios do sistema imunitário e, segundo o registro, não há evidências de gravidade significativa nem desfecho informado, sugerindo um quadro leve, mas que exige avaliação médica para confirmação e conduta apropriada.

O medicamento Janumet, que contém cloridrato de metformina e fosfato de sitagliptina monoidratado, foi associado a uma erupção medicamentosa pustulosa, caracterizada por lesões de pele com pus decorrentes de hipersensibilidade. Essa reação envolve o sistema imunológico e, conforme os dados, não há indicação de gravidade relevante nem desfecho conhecido, o que sugere um quadro leve, mas que deve ser acompanhado por um profissional de saúde para avaliação e manejo.

O medicamento Cloridrato de fluoxetina, cujo princípio ativo é a fluoxetina, foi relacionado a uma erupção medicamentosa pustulosa, uma reação de hipersensibilidade que se manifesta por lesões cutâneas com pus. Essa resposta faz parte dos distúrbios do sistema imunitário e, de acordo com o registro, não há sinais de gravidade importante nem desfecho informado, indicando um quadro leve, mas que requer avaliação médica para orientação sobre a continuidade do tratamento.

O medicamento CoronaVac, cujo princípio ativo é COVID-19 vaccine inact (Vero) CZ02, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado por uma reação do sistema imunológico a substâncias presentes na vacina. A gravidade do caso é considerada clinicamente significativa, pois foi classificada como grave e o paciente ainda não se recuperou, estando com sintomas em andamento. Diante desse cenário, é fundamental acompanhamento médico especializado para monitoramento e manejo adequado da reação, evitando novas exposições ao agente suspeito e priorizando a segurança do paciente.

O medicamento Comirnaty, que tem como princípio ativo o Tozinameran, esteve relacionado a um episódio de arritmia associado a hipersensibilidade, indicando uma reação alérgica do sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, mas o paciente evoluiu para recuperação completa. Em situações como essa, é importante que o paciente seja avaliado por um médico para investigação da causa da reação e orientação sobre o uso futuro do medicamento, garantindo segurança em novas administrações.

O medicamento Xolair, cujo princípio ativo é Omalizumab, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade durante um episódio de COVID-19, sugerindo uma reação alérgica do sistema imunológico. Neste caso, a gravidade não foi classificada como grave e o paciente encontra-se em recuperação. Recomenda-se acompanhamento clínico para monitorar a evolução dos sintomas e avaliar a necessidade de ajustes no

tratamento, sempre sob orientação médica.

O medicamento COVID-19 vaccine AstraZeneca, com princípio ativo COVID-19 vaccine NRVV Ad (ChAdOx1 nCoV-19), foi associado a um caso de câncer renal em contexto de hipersensibilidade, sendo considerado um evento de ameaça à vida e classificado como grave. Apesar da gravidade, o paciente se recuperou do evento. Diante de reações graves como essa, é essencial investigação médica detalhada para esclarecer a relação causal e orientar condutas futuras, priorizando a segurança do paciente.

O medicamento Iron, cujo princípio ativo também é Iron, esteve relacionado a um quadro de broncopneumonia em contexto de hipersensibilidade, indicando uma reação alérgica do sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, mas o desfecho permanece desconhecido. Nesses casos, é fundamental acompanhamento médico para avaliação da evolução clínica e definição das melhores estratégias de manejo, evitando novas exposições ao agente suspeito.

O medicamento Clavulin, que contém os princípios ativos amoxicilina tri-hidratada e potássio de clavulanato, foi associado a um quadro de broncopneumonia relacionado à hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. A gravidade do evento é considerada clinicamente significativa, pois envolve complicação respiratória importante, conforme registrado. O desfecho do caso é desconhecido, e a relação do medicamento com a reação foi considerada suspeita.

O medicamento Montelair, cujo princípio ativo é o montelucaste de sódio, foi relacionado a um episódio de broncopneumonia decorrente de hipersensibilidade, caracterizando uma resposta alérgica do sistema imunológico. O evento foi classificado como clinicamente significativo devido à gravidade da complicação respiratória apresentada. O desfecho permanece desconhecido e a suspeita de relação com o medicamento foi registrada.

Montelair, contendo montelucaste de sódio, esteve envolvido em um caso de broncopneumonia atribuída à hipersensibilidade, indicando uma reação alérgica relevante do sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente significativo por envolver comprometimento respiratório, e o desfecho não foi informado. A relação do medicamento com a reação foi considerada suspeita.

O medicamento Soliris, cujo princípio ativo é o eculizumabe, foi associado a um quadro de broncopneumonia relacionado à hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente significativo devido à gravidade da manifestação respiratória. O desfecho do caso não foi informado e a relação com o medicamento foi considerada suspeita.

Soliris, com princípio ativo eculizumabe, esteve envolvido em um episódio de broncopneumonia atribuída à hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica relevante do sistema imunológico. O evento foi classificado como clinicamente significativo por envolver complicação respiratória importante, sem informação sobre o desfecho, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita.

O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é o Tozinameran, foi associado a dor de garganta em um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Neste caso, a reação foi considerada grave devido à incapacidade persistente ou significativa relatada, e o desfecho permanece não resolvido, indicando que o paciente ainda apresenta sintomas. A relação entre o medicamento e o evento adverso é considerada suspeita, sendo fundamental acompanhamento médico para monitoramento e manejo adequado da reação.

O medicamento Buscopan, com princípio ativo Hyoscine butylbromide, foi relacionado a um episódio de alergia em olhos, ouvidos e garganta (SOE), caracterizado como hipersensibilidade, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave e o paciente se recuperou totalmente após a conduta adotada, não havendo complicações ou necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Reuquinol, cujo princípio ativo é Hydroxychloroquine sulfate, foi associado ao desenvolvimento de cálculo renal em um contexto de hipersensibilidade, classificado como distúrbio do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave e o paciente apresentou recuperação completa após o evento, sem necessidade de medidas adicionais.

O medicamento Paracetamol, com o mesmo princípio ativo, foi relacionado ao surgimento de cálculo renal em um quadro de hipersensibilidade, enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, não havendo relato de complicações persistentes.

O medicamento Benlysta, cujo princípio ativo é Belimumab, foi associado ao aparecimento de cálculo renal em um contexto de hipersensibilidade, classificado como distúrbio do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave e o paciente apresentou resolução completa do quadro, sem necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é o Tozinameran, foi associado ao surgimento de tosse seca, um sintoma que pode indicar uma reação de hipersensibilidade (alergia) envolvendo o sistema imunológico. A gravidade do evento é considerada clinicamente significativa, pois foi classificada como grave, sugerindo a necessidade de atenção médica para investigação e manejo adequado. O desfecho da reação é desconhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo importante monitorar o paciente e buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e definição da conduta.

O medicamento Irinotecan, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um quadro de alergia medicamentosa, caracterizado por hipersensibilidade a medicamentos e envolvendo o sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, o que reforça a necessidade de avaliação médica imediata para confirmação do diagnóstico e orientação sobre a suspensão ou substituição do medicamento, além de medidas de suporte conforme a gravidade da reação. O desfecho permanece desconhecido e a relação com o uso do medicamento é suspeita.

O medicamento Oxaliplatin, cujo princípio ativo também é Oxaliplatin, apresentou relato de alergia medicamentosa, manifestando-se como uma reação de hipersensibilidade relevante do ponto de vista clínico e classificada como grave. Esse tipo de reação pode envolver sintomas variados e requer avaliação médica urgente para confirmação, manejo adequado e possível interrupção do tratamento, já que a relação com o medicamento é considerada suspeita e o desfecho ainda não foi informado.

O medicamento Fluorouracil, com princípio ativo de mesmo nome, foi associado a um episódio de alergia medicamentosa, caracterizado por hipersensibilidade relevante do ponto de vista clínico e classificada como grave. Diante desse quadro, é fundamental buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica, orientação sobre a continuidade ou suspensão do tratamento e adoção de medidas de suporte, já que a relação com o medicamento é suspeita e o desfecho da reação não foi informado.

O medicamento Folinic acid, cujo princípio ativo também é Folinic acid, foi relacionado a uma reação de alergia medicamentosa, manifestando-se como hipersensibilidade clinicamente significativa e considerada grave. Esse tipo de evento exige avaliação médica imediata para confirmação do diagnóstico, definição da conduta terapêutica e monitoramento do paciente, pois a relação com o medicamento é suspeita e o desfecho da reação permanece desconhecido.

O medicamento Erbitux, cujo princípio ativo é o cetuximabe, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado como uma reação imunológica adversa. A gravidade foi considerada clinicamente significativa, pois o registro indica um efeito importante para a saúde do paciente. Não há detalhes sobre a evolução do caso, mas, diante da gravidade, recomenda-se acompanhamento médico rigoroso, investigação de outros possíveis fatores de risco e, se necessário, suspensão do medicamento, conforme orientação especializada.

O medicamento Comirnaty, com princípio ativo tozinamerana, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), descrito como um quadro alérgico sem gravidade significativa, já que não há menção de risco à vida ou necessidade de hospitalização. O evento ainda está em andamento, sem resolução completa, sendo importante manter o acompanhamento clínico para monitorar a evolução dos sintomas e garantir a segurança do paciente.

O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é tozinamerana, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) considerada clinicamente significativa, indicando um impacto relevante para o paciente. Não há informações detalhadas sobre o desfecho, mas a gravidade relatada exige avaliação médica cuidadosa, possível suspensão do uso e investigação de alternativas terapêuticas, conforme orientação do especialista.

O medicamento CoronaVac, com princípio ativo vacina COVID-19 inativada (Vero) CZ02, foi relacionado a dor de cabeça em contexto de hipersensibilidade, mas sem gravidade relevante, já que não houve ameaça à vida ou necessidade de hospitalização. O paciente encontra-se em recuperação, sugerindo que a reação está se resolvendo espontaneamente, sendo importante apenas o acompanhamento clínico para garantir a completa resolução dos sintomas.

O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é tozinamerana, foi associado a uma sensação anormal (descrita como 'sensação esquisita') em contexto de hipersensibilidade, com gravidade elevada, pois houve ameaça à vida e necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação. O evento permanece sem resolução, sendo fundamental o acompanhamento médico intensivo, monitoramento rigoroso e avaliação de risco-benefício para continuidade do tratamento.

A vacina adsorvida COVID-19 (inativada), cujo princípio ativo é COVID-19 vaccine inact (Vero) CZ02, foi associada a um quadro de alergia a picada de artrópode, classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Embora o termo técnico utilizado seja amplo, o evento foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente, não havendo indicação de complicações ou necessidade de intervenção médica adicional.

A Dipirona, cujo princípio ativo é Metamizole sodium, foi relacionada a um episódio de hipertensão descrito como hipersensibilidade, um tipo de reação alérgica do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade ou desfecho desfavorável, sugerindo que o quadro foi leve e não exigiu conduta médica específica, com evolução provavelmente benigna.

O Cetoprofeno, com princípio ativo Ketoprofen, esteve associado a um caso de hipertensão interpretado como hipersensibilidade, indicando uma reação alérgica do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade ou complicações relatadas, o que sugere que a reação foi leve e não houve necessidade de medidas adicionais, com provável resolução espontânea.

O medicamento Tramadol, cujo princípio ativo é Tramadol hydrochloride, foi relacionado a um episódio de hipertensão classificado como hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunitário. Não há indícios de gravidade ou desfecho negativo, indicando que o evento foi leve e não demandou intervenções específicas, com provável evolução favorável.

O Xolair, que tem como princípio ativo o Omalizumab, foi associado a um quadro de imunodeficiência descrito como hipersensibilidade, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, mas permanece em andamento sem resolução até o momento, o que sugere a necessidade de acompanhamento clínico para monitoramento da evolução.

O medicamento Reliev, cujo princípio ativo é o meglumine amidotrizoate, foi associado a um episódio de alergia a contraste, uma reação do sistema imunológico a substâncias químicas utilizadas em exames de imagem. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, pois o desfecho foi de recuperação completa, sugerindo que a reação foi controlada adequadamente. A conduta recomendada em situações semelhantes é interromper a exposição ao

contraste e monitorar o paciente, buscando avaliação médica para confirmação e orientação sobre futuras exposições.

O medicamento Reactine, que contém cetirizina, foi relacionado a um quadro de urticária crônica espontânea, caracterizada por lesões avermelhadas e coceira na pele sem causa aparente, sendo uma manifestação de hipersensibilidade medicamentosa. Não há evidência de gravidade significativa, já que o paciente se recuperou totalmente e não houve indicação de gravidade clínica. Nesses casos, recomenda-se suspender o uso do medicamento suspeito e procurar orientação médica para avaliação e controle dos sintomas.

O medicamento Prednisolone, com princípio ativo prednisolona, foi associado a um episódio de urticária crônica espontânea, que se manifesta por placas avermelhadas e prurido recorrente, indicando uma possível hipersensibilidade ao medicamento. O caso não foi considerado grave, pois houve resolução completa dos sintomas. A conduta adequada é interromper o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição do tratamento.

O medicamento Atenolol, cujo princípio ativo é o atenolol, foi relacionado a um episódio de urticária crônica espontânea, caracterizada por lesões de pele e coceira persistente, sugerindo uma reação de hipersensibilidade. Não há sinais de gravidade, já que o paciente se recuperou totalmente. Recomenda-se suspender o uso do medicamento e procurar avaliação médica para investigação e manejo adequado da reação.

O medicamento Benicar, com princípio ativo olmesartan medoxomil, foi associado a um quadro de urticária crônica espontânea, que se manifesta por lesões avermelhadas e prurido recorrente, indicando uma possível hipersensibilidade ao medicamento. O caso não foi considerado grave, pois houve resolução completa dos sintomas. A conduta recomendada é suspender o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição do tratamento.

O medicamento Xolair, cujo princípio ativo é o Omalizumab, foi associado a um quadro de urticária crônica espontânea, caracterizado por hipersensibilidade medicamentosa. Trata-se de uma reação alérgica do tipo imunológica, envolvendo sintomas como lesões avermelhadas e coceira na pele, sem sinais de gravidade clínica relevante, já que não há menção de complicações graves e o desfecho foi de recuperação completa. A conduta recomendada, conforme diretrizes clínicas, é a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento médico para controle dos sintomas, sendo importante relatar o episódio ao especialista para evitar novas exposições.

O Reactine, que contém cetirizina como princípio ativo, foi relacionado a um episódio de urticária crônica espontânea, descrito como hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade significativa, pois não foram relatados sintomas sistêmicos graves ou necessidade de intervenção urgente, e o desfecho permanece desconhecido. Recomenda-se observar a evolução clínica e buscar orientação médica para confirmação do diagnóstico e ajuste do tratamento, evitando o uso do medicamento suspeito até avaliação especializada.

O medicamento Prednisolone, com princípio ativo de mesmo nome, foi associado a um caso de urticária crônica espontânea, caracterizado por hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indícios de gravidade importante, pois não foram relatados sintomas sistêmicos ou complicações, e o desfecho não foi informado. A recomendação é suspender o uso do medicamento suspeito e procurar avaliação médica para investigação da causa e definição do melhor manejo, evitando automedicação.

O Atenolol, cujo princípio ativo também é Atenolol, foi relacionado a um episódio de urticária crônica espontânea, caracterizado por hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade clínica relevante, pois não foram relatados sintomas sistêmicos graves ou necessidade de intervenção urgente, e o desfecho permanece desconhecido. Recomenda-se interromper o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas terapêuticas.

O Benicar, que tem como princípio ativo o Olmesartan medoxomil, foi associado a um quadro de urticária crônica espontânea, caracterizado por hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade significativa, pois não foram relatados sintomas sistêmicos graves ou necessidade de intervenção urgente, e o desfecho é desconhecido. A conduta recomendada é suspender o medicamento suspeito e procurar avaliação médica para investigação da causa e definição do tratamento mais seguro.

O medicamento Xolair, cujo princípio ativo é o Omalizumabe, foi associado a um quadro de urticária crônica espontânea, caracterizado por hipersensibilidade e manifestações alérgicas do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações graves, e o desfecho do caso é desconhecido, sem informações sobre a evolução clínica ou conduta adotada até o momento.

O medicamento Ciclo, composto por etinilestradiol e levonorgestrel, esteve relacionado a fenômenos semelhantes à convulsão, descritos como uma reação de hipersensibilidade do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade importante ou risco imediato, mas o quadro permanece não resolvido ou em andamento, sem informações detalhadas sobre a conduta adotada ou evolução clínica.

O Xolair, com princípio ativo Omalizumabe, foi associado a fenômenos semelhantes à convulsão, classificados como reação de hipersensibilidade do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade significativa ou complicações graves, e o caso segue sem resolução até o momento, sem detalhes sobre a conduta adotada.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o Iopromida, foi relacionado a um episódio de alergia a contraste, caracterizado por reação alérgica do sistema imunológico a substâncias químicas. Não há indicação de gravidade elevada, e o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente após o evento.

O Ultravist, com princípio ativo Iopromida, também esteve envolvido em um caso de alergia a contraste, manifestando-se como reação alérgica do sistema imunológico. O quadro não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação total após o episódio.

O medicamento Concardio, cujo princípio ativo é o bisoprolol fumarato, foi associado à retenção de líquido em um caso classificado como hipersensibilidade (reação alérgica), pertencente ao grupo de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois não há relato de complicações graves ou risco imediato à vida, e o desfecho informado é de não recuperação ou situação ainda em andamento. A conduta recomendada é monitorar os sintomas e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre a continuidade do tratamento, considerando que a reação não foi grave, mas persiste.

O Entresto, que contém sacubitril e valsartana como princípios ativos, apresentou relato de retenção de líquido atribuída a uma reação de hipersensibilidade (alergia), enquadrada nos distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa, pois não foi relatada gravidade elevada nem desfecho crítico, estando o caso ainda não resolvido. Recomenda-se acompanhamento clínico para avaliação da evolução dos sintomas e ajuste do tratamento, já que a reação não foi considerada grave, mas permanece em andamento.

O Concardio, com bisoprolol fumarato como princípio ativo, foi relacionado a um episódio de retenção de líquido classificado como hipersensibilidade medicamentosa, dentro do contexto de alergias a medicamentos e distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade aumentada, pois não há relato de complicações graves ou risco imediato, e o desfecho é desconhecido. A orientação é manter vigilância dos sintomas e buscar avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e definição da conduta, considerando que a reação não foi considerada grave.

O medicamento Entresto, composto por sacubitril e valsartana, foi associado à retenção de líquido em um caso de hipersensibilidade medicamentosa, classificada como alergia a medicamentos e distúrbios do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade relevante, pois não foi relatada gravidade elevada e o desfecho permanece desconhecido. Recomenda-se acompanhamento médico para avaliação dos sintomas e definição do manejo, já

que a reação não foi considerada grave.

A vacina COVID-19 AstraZeneca, cujo princípio ativo é a vacina COVID-19 NRVV Ad (ChAdOx1 nCoV-19), foi relacionada a um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, dentro do grupo de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade aumentada, pois não há relato de complicações graves ou risco imediato, e o desfecho informado é de não recuperação ou situação ainda em andamento. A recomendação é monitorar os sintomas e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre a continuidade da vacinação, considerando que a reação não foi grave, mas persiste.

O medicamento COVID-19 vaccine AstraZeneca, cujo princípio ativo é COVID-19 vaccine NRVV Ad (ChAdOx1 nCoV-19), foi associado ao evento de cefaleia (dor de cabeça) em um caso classificado como hipersensibilidade, dentro do contexto de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. A reação foi considerada clinicamente significativa, sendo classificada como grave devido à sua relevância clínica, e o paciente evoluiu para recuperação completa. A relação entre o medicamento e o evento foi considerada suspeita, e não há informações adicionais sobre condutas específicas adotadas, mas o desfecho foi favorável.

O medicamento Cyclosporine, com princípio ativo Ciclosporin, foi relacionado ao agravamento de artrite psoriática, um quadro de hipersensibilidade enquadrado em distúrbios do sistema imunitário. Apesar de não haver indicação de gravidade elevada neste caso, a relação com o medicamento é considerada suspeita e o desfecho permanece desconhecido, não havendo detalhes sobre a conduta adotada ou evolução clínica.

O medicamento Acitretin, cujo princípio ativo é Acitretin, foi associado ao agravamento de artrite psoriática, caracterizando um quadro de hipersensibilidade e distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade relevante neste caso, a relação com o medicamento é suspeita e o desfecho não foi informado, assim como não há detalhes sobre a conduta adotada.

O medicamento Cosentyx, com princípio ativo Secukinumab, foi relacionado ao agravamento de artrite psoriática, sendo um quadro de hipersensibilidade dentro dos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, a relação com o medicamento é suspeita e o desfecho permanece desconhecido, sem informações sobre a conduta tomada.

O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é Tozinameran, foi associado ao evento de cefaleia (dor de cabeça) em um contexto de hipersensibilidade e distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave, a relação com o medicamento é suspeita e o paciente evoluiu para recuperação completa, sem detalhes adicionais sobre a conduta adotada.

O medicamento COVID-19 vaccine AstraZeneca, cujo princípio ativo é COVID-19 vaccine NRVV Ad (ChAdOx1 nCoV-19), foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como clinicamente significativo e grave, pois o evento não foi resolvido até o momento. A reação envolve o sistema imunológico e se enquadra em quadros clínicos alérgicos, sendo importante acompanhamento médico para monitoramento e manejo adequado, conforme a gravidade relatada.

O medicamento Comirnaty, com princípio ativo Tozinameran, foi relacionado a um episódio de artralgia (dor nas articulações) associado a hipersensibilidade, considerado clinicamente significativo e grave, embora o desfecho ainda seja desconhecido. A reação envolve o sistema imunológico e se encaixa em quadros alérgicos, sendo recomendada avaliação médica para investigação e conduta apropriada diante da gravidade do evento.

O medicamento Diclofenaco potássico, cujo princípio ativo é Diclofenac potassium, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade) envolvendo o sistema imunológico, mas não foi classificado como grave e não há informações sobre o desfecho. Diante da ausência de gravidade, a conduta deve ser baseada na avaliação clínica dos sintomas e acompanhamento conforme necessidade.



O medicamento Comirnaty, com princípio ativo Tozinameran, foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade) classificado como clinicamente significativo e grave, pois o evento permanece não resolvido. A reação envolve o sistema imunológico e se enquadra em quadros clínicos alérgicos, sendo fundamental acompanhamento médico para monitoramento e definição da conduta adequada.

O medicamento CoronaVac, cujo princípio ativo é COVID-19 vaccine inact (Vero) CZ02, foi associado a calafrios relacionados a hipersensibilidade, classificados como clinicamente significativos e graves, com o evento ainda em andamento. A reação envolve o sistema imunológico e se encaixa em quadros alérgicos, sendo importante acompanhamento médico para avaliação e manejo conforme a gravidade apresentada.

O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é o Tozinameran, foi associado a dor no braço, classificada como um quadro de hipersensibilidade (alergia), pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. A reação foi considerada clinicamente significativa, sendo classificada como grave, conforme indicado no registro. O desfecho da reação é desconhecido, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita. Em situações de hipersensibilidade clinicamente relevante, recomenda-se avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição da conduta, especialmente se houver sinais de gravidade.

O medicamento Xolair, com princípio ativo Omalizumabe, foi relacionado a um episódio de edema de glote, caracterizado como hipersensibilidade (alergia) e enquadrado nos distúrbios do sistema imunitário. Apesar da gravidade potencial do edema de glote, o registro não classificou o caso como grave e o desfecho permanece desconhecido. Diante de qualquer suspeita de reação alérgica envolvendo vias aéreas superiores, é fundamental buscar avaliação médica imediata para manejo adequado e prevenção de complicações.

O medicamento Rocefin, cujo princípio ativo é o Ceftriaxona sódica, foi associado a um quadro de alergia, classificado como hipersensibilidade e pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente evoluiu para recuperação completa. Em situações de alergia medicamentosa sem gravidade, recomenda-se suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento médico para evitar novas exposições e orientar alternativas terapêuticas.

O medicamento Cloridrato de ciprofloxacino, com princípio ativo Ciprofloxacino, foi relacionado a um episódio de alergia, caracterizado como hipersensibilidade e enquadrado nos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente. Em casos de alergia leve a medicamentos, a conduta adequada é interromper o uso do fármaco suspeito e buscar orientação médica para avaliação e prevenção de recorrências.

O medicamento COVID-19 vaccine AstraZeneca, cujo princípio ativo é a vacina COVID-19 NRVV Ad (ChAdOx1 nCoV-19), foi associado a um quadro de alergia classificado como hipersensibilidade, pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. A reação foi considerada clinicamente significativa e classificada como grave, mas o paciente evoluiu para recuperação completa. Em casos de reações alérgicas graves a vacinas, é fundamental interromper a exposição, realizar avaliação médica especializada e monitorar o paciente até resolução dos sintomas.

O medicamento Optiray 320, cujo princípio ativo é o ioversol, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário. A reação foi descrita de forma geral como um quadro clínico alérgico, sem detalhamento de sintomas específicos ou gravidade, mas o desfecho informado foi de recuperação completa, indicando resolução do evento após a conduta adotada.

O medicamento Paroxetine hydrochloride, com o mesmo princípio ativo, foi relacionado a um quadro de alergia a poeira (alergia a ácaros), caracterizado como um distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, pois permanece em andamento sem resolução até o momento, sugerindo necessidade de acompanhamento médico para controle dos sintomas e investigação de possíveis gatilhos ambientais.

O medicamento Pondera, cujo princípio ativo é paroxetine hydrochloride, foi associado a um quadro de alergia a poeira (alergia a ácaros), classificado como distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, permanecendo sem resolução, o que reforça a importância de avaliação médica para manejo adequado e identificação de fatores desencadeantes.

O medicamento Fluoxetine, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um quadro de alergia a poeira (alergia a ácaros), enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, não apresentando resolução até o momento, o que indica necessidade de acompanhamento especializado para controle dos sintomas e investigação de causas.

O medicamento Xolair, cujo princípio ativo é omalizumabe, foi associado a um quadro de alergia a poeira (alergia a ácaros), classificado como distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, permanecendo sem resolução, o que sugere a necessidade de acompanhamento médico contínuo para ajuste do tratamento e controle dos sintomas alérgicos.

O medicamento Paroxetine hydrochloride, cujo princípio ativo é também Paroxetine hydrochloride, foi associado a um quadro de alergia a poeira, caracterizado como um distúrbio do sistema imunitário e classificado como clinicamente significativo. A gravidade é sustentada pelo registro de que o evento foi considerado grave e não houve recuperação até o momento, indicando que a reação permanece em andamento. A conduta recomendada é buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica, identificação de gatilhos e controle ambiental, conforme orientações para quadros alérgicos persistentes.

O medicamento Pondera, que tem como princípio ativo Paroxetine hydrochloride, apresentou relato de alergia a poeira, um quadro alérgico do sistema imunitário considerado clinicamente relevante. O evento foi classificado como grave e ainda não resolvido, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico para investigação dos sintomas, controle dos fatores ambientais e definição de um plano terapêutico adequado.

O medicamento Fluoxetine, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um episódio de alergia a poeira, enquadrado como distúrbio do sistema imunitário e considerado clinicamente significativo. O caso foi classificado como grave e permanece sem resolução, o que indica a importância de avaliação clínica estruturada, identificação de possíveis gatilhos e controle ambiental contínuo para manejo adequado da reação.

O medicamento Xolair, cujo princípio ativo é Omalizumab, foi associado a um quadro de alergia a poeira, caracterizado como distúrbio do sistema imunitário e considerado clinicamente relevante. O evento foi classificado como grave e não resolvido, sugerindo a necessidade de acompanhamento médico para confirmação diagnóstica, controle dos fatores desencadeantes e ajuste do tratamento conforme a evolução clínica.

O medicamento Optiray, com princípio ativo Ioversol, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Embora não haja detalhamento sobre a gravidade, o desfecho foi de recuperação completa, indicando que a reação foi resolvida após a adoção das medidas necessárias, sem complicações persistentes.

O medicamento Fisiogel, cujo princípio ativo é Soft soap, foi associado a inchaço no local de aplicação, caracterizando uma reação de hipersensibilidade (alergia) de leve intensidade, pois não há indicação de gravidade ou desfecho grave. Essa manifestação sugere uma resposta alérgica localizada, comum em quadros clínicos alérgicos do sistema imunitário, e não há informações sobre evolução ou necessidade de intervenção médica adicional.

O medicamento Aldactone, com princípio ativo Spironolactone, apresentou relato de inchaço no local de aplicação, indicando uma reação de hipersensibilidade (alergia) leve, já que não há sinais de gravidade ou complicações. Trata-se de uma resposta alérgica localizada, compatível com quadros alérgicos do sistema imunitário, sem informações sobre evolução clínica ou necessidade de conduta específica.

O medicamento Ecasil, cujo princípio ativo é Acetylsalicylic acid, foi relacionado a inchaço no local de aplicação, caracterizando uma reação de hipersensibilidade (alergia) leve, pois não há evidências de gravidade ou desfecho grave. Essa reação sugere uma resposta alérgica localizada do sistema imunitário, sem detalhes adicionais sobre evolução ou necessidade de intervenção médica.

O medicamento Flaboido, com princípio ativo Prazosin hydrochloride, foi associado a inchaço no local de aplicação, indicando uma reação de hipersensibilidade (alergia) leve, já que não há sinais de gravidade ou complicações. Trata-se de uma resposta alérgica localizada do sistema imunitário, sem informações sobre evolução clínica ou necessidade de conduta específica.

O medicamento Neovite lutein, composto pelos princípios ativos Ascorbic acid, Selenium, Vitamin E, Xantofyl, Zeaxanthin e Zinc, foi relacionado a inchaço no local de aplicação, caracterizando uma reação de hipersensibilidade (alergia) leve, pois não há evidências de gravidade ou desfecho grave. Essa manifestação sugere uma resposta alérgica localizada do sistema imunitário, sem detalhes adicionais sobre evolução ou necessidade de intervenção médica.

O medicamento Trayenta, cujo princípio ativo é a linagliptina, foi associado a inchaço no local de aplicação, caracterizando um quadro de hipersensibilidade (alergia), conforme descrito em reações alérgicas do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave neste caso, sugerindo que a reação foi leve e localizada, sem informações adicionais sobre a evolução ou necessidade de intervenção específica.

O medicamento Indapen, com princípio ativo indapamida, apresentou relato de inchaço no local de aplicação, compatível com uma reação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade significativa ou complicações graves, indicando que a manifestação foi leve e restrita ao local, sem detalhes sobre a evolução clínica ou conduta adotada.

O medicamento Benicar, cujo princípio ativo é olmesartana medoxomila, foi relacionado a inchaço no local de aplicação, caracterizando uma reação alérgica leve do tipo hipersensibilidade, sem sinais de gravidade ou desfecho grave relatados, sugerindo que o evento foi localizado e não houve complicações importantes.

O medicamento Insulin, com princípio ativo insulina, apresentou relato de inchaço no local de aplicação, indicando uma reação alérgica leve (hipersensibilidade) do sistema imunológico, sem evidências de gravidade ou evolução desfavorável, e sem informações adicionais sobre a conduta adotada.

O medicamento Glifage, cujo princípio ativo é metformina, foi associado a inchaço no local de aplicação, caracterizando uma reação alérgica leve do tipo hipersensibilidade, sem sinais de gravidade ou desfecho grave, sugerindo que o evento foi restrito ao local e não houve complicações relevantes.

O medicamento Exelon, cujo princípio ativo é rivastigmina, foi associado a inchaço no local de aplicação, caracterizando um quadro de hipersensibilidade (alergia) relacionado ao sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou necessidade de hospitalização, e o desfecho da reação é desconhecido. A conduta recomendada, conforme diretrizes clínicas, é observar o paciente, evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação médica caso o quadro persista ou piore.

O medicamento Nactali, que contém desogestrel, foi relacionado a um episódio de alergia às proteínas do leite de vaca, caracterizando uma reação alérgica alimentar importante. O caso foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, e o paciente encontra-se em recuperação. Diante de reações alérgicas graves, a recomendação é suspender imediatamente o uso do medicamento suspeito, garantir suporte clínico adequado e acompanhamento especializado para evitar novas exposições e controlar possíveis complicações.

O medicamento Dotarem, cujo princípio ativo é meglumina gadoterato, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), envolvendo o sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade aumentada ou necessidade de hospitalização, e o paciente já se recuperou totalmente. Nestes casos, recomenda-se evitar nova exposição ao agente suspeito e informar o médico sobre o episódio para futuras decisões terapêuticas.

O medicamento Dipyrone, com princípio ativo metamizol, foi relacionado a uma fratura do pé, mas não há evidências clínicas de que este evento seja uma reação alérgica ou de hipersensibilidade medicamentosa, nem indicação de gravidade ou desfecho relevante. A relação causal entre o medicamento e o evento não está clara, sendo importante relatar o caso ao médico para avaliação individualizada.

O medicamento Actemra, cujo princípio ativo é tocilizumabe, foi associado a uma fratura do pé, mas não há evidências clínicas de que este evento represente uma reação alérgica ou de hipersensibilidade ao medicamento, nem indicação de gravidade ou desfecho relevante. A relação entre o uso do medicamento e o evento não está estabelecida, sendo fundamental discutir o caso com o médico responsável para esclarecimento.

O medicamento Omega 3, cujo princípio ativo é o óleo de salmão (Salmon oil), foi associado a um quadro de perda de visão, descrito como uma reação de hipersensibilidade (alergia), classificada clinicamente como um distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou risco imediato, pois não há menção de gravidade clínica ou desfecho fatal, e o caso permanece não resolvido ou em andamento. A reação sugere um quadro alérgico não especificado, e recomenda-se acompanhamento médico para avaliação e manejo adequado, conforme diretrizes de farmacovigilância.

O medicamento Plasil, cujo princípio ativo é o cloridrato de metoclopramida (Metoclopramide hydrochloride), foi relacionado a perda de visão em um contexto de hipersensibilidade, caracterizando um quadro alérgico do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade crítica ou risco imediato, já que o caso está em andamento e não foi classificado como grave. Recomenda-se avaliação médica para investigação da reação e orientação sobre a continuidade ou suspensão do uso, seguindo as recomendações de segurança para reações adversas medicamentosas.

O medicamento Indapamida, com princípio ativo indapamida, foi associado a perda de visão em um contexto de hipersensibilidade, indicando uma possível reação alérgica do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade elevada ou risco imediato, pois o caso não foi classificado como grave e permanece não resolvido. É importante buscar avaliação médica para investigação da causa e definição da conduta, conforme as orientações para reações adversas a medicamentos.

O medicamento Amlodipina, cujo princípio ativo é o mesilato de anlodipino (Amlodipine mesilate), foi relacionado a perda de visão em um quadro de hipersensibilidade, sugerindo uma reação alérgica do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade crítica, já que o caso não foi considerado grave e está em andamento. Recomenda-se acompanhamento médico para avaliação detalhada e definição do manejo, conforme protocolos de farmacovigilância.

O medicamento Aradois, com princípio ativo losartana potássica (Losartan potassium), foi associado a perda de visão em um contexto de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade elevada ou risco imediato, pois o caso não foi classificado como grave e permanece não resolvido. É fundamental procurar avaliação médica para investigação da reação e orientação sobre o uso do medicamento, conforme recomendações de segurança em farmacovigilância.

O medicamento Cimzia, cujo princípio ativo é o certolizumabe pegol, foi associado a um quadro de perda de visão relacionado a hipersensibilidade, um tipo de reação alérgica que pode afetar o sistema imunológico. Embora a gravidade não tenha sido explicitamente classificada como grave, o fato de o desfecho estar em andamento e não resolvido indica a necessidade de acompanhamento médico contínuo para monitorar a evolução do quadro e avaliar possíveis intervenções.

No caso da metoclopramida (princípio ativo metoclopramida), foi relatada uma alergia documentada ao medicamento administrado, caracterizando uma reação de hipersensibilidade comprovada. A ausência de informações sobre gravidade e desfecho impede uma avaliação mais detalhada, mas a confirmação da alergia exige suspensão do uso e registro em prontuário para evitar futuras exposições.

O Panthenol, com princípio ativo panthenol, foi relacionado a um episódio de sangramento associado a hipersensibilidade, sugerindo uma reação alérgica que envolveu o sistema imunológico. Apesar de não ter sido classificado como grave, o fato de o quadro não estar resolvido reforça a importância de acompanhamento médico para avaliar a necessidade de medidas adicionais e evitar novas exposições ao agente.

O medicamento Cosentyx, cujo princípio ativo é o secuquinumabe, foi associado a um episódio de sangramento relacionado a hipersensibilidade, indicando uma reação alérgica que envolveu o sistema imunológico. Embora não tenha sido considerado grave e o desfecho ainda esteja em andamento, é fundamental manter o acompanhamento clínico para monitorar a evolução e orientar a conduta adequada.

O contraste Ultravist, com princípio ativo iopromida, foi relacionado a uma reação alérgica ao contraste, caracterizada por hipersensibilidade ao produto. O quadro foi resolvido, indicando que as medidas adotadas foram eficazes e não houve evolução para complicações, mas é importante registrar a alergia para evitar futuras exposições ao mesmo tipo de contraste.

O medicamento Neutrofer, cujo princípio ativo é o ferroglicinato quelato, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado como clinicamente significativo e considerado grave, conforme evidenciado pela classificação de gravidade e pelo destaque para distúrbios do sistema imunitário. O paciente se recuperou totalmente após a reação, indicando resolução do quadro após a conduta adequada, que deve sempre envolver a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento médico para evitar novas exposições.

O Euthyrox, que contém levotiroxina sódica como princípio ativo, desencadeou uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), classificada como clinicamente significativa e grave, com envolvimento do sistema imunitário. O paciente evoluiu para recuperação completa após a reação, reforçando a importância de identificar e evitar o uso do medicamento em casos de hipersensibilidade confirmada, sempre sob orientação médica.

O medicamento Pasurta, cujo princípio ativo é o erenumabe, foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), considerado clinicamente significativo e grave, com envolvimento do sistema imunitário. O paciente apresentou recuperação total após a reação, o que destaca a necessidade de acompanhamento médico rigoroso e suspensão do agente suspeito em casos de hipersensibilidade.

O Ioversol, utilizado como meio de contraste, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade), envolvendo o sistema imunitário, mas sem gravidade significativa relatada. O paciente se recuperou completamente após o evento, indicando que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro, sendo fundamental informar a equipe médica sobre o episódio em futuras exposições.

O medicamento Clindamicin, com princípio ativo clindamicina fosfato, provocou uma reação alérgica (hipersensibilidade) envolvendo o sistema imunitário, sem gravidade relevante registrada. O paciente apresentou recuperação total após o evento, ressaltando a importância de evitar o uso futuro do medicamento e comunicar o histórico de alergia ao profissional de saúde.

O medicamento Novalgina, cujo princípio ativo é o metamizol sódico, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta

recomendada em situações semelhantes é suspender o uso do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Carbamazepina, com princípio ativo carbamazepina, foi relacionado a um acidente vascular cerebral em um contexto de hipersensibilidade, o que sugere uma reação imunológica adversa. Apesar de não ter sido classificado como grave, o desfecho indica que o paciente ainda não se recuperou ou está em processo de recuperação. Diante de eventos neurológicos associados a medicamentos, é fundamental interromper o uso e procurar avaliação médica urgente para investigação e manejo adequado.

A amoxicilina, cujo princípio ativo é amoxicilina sódica, foi associada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), caracterizando uma reação do sistema imunológico. Não há informações detalhadas sobre gravidade ou evolução do caso, mas em situações de suspeita de alergia a antibióticos, recomenda-se suspender o uso imediatamente e buscar orientação médica para avaliação e definição de alternativas terapêuticas seguras.

O medicamento Comirnaty, com princípio ativo tozinamerana, foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), indicando uma resposta do sistema imunológico ao imunizante. Não há detalhes sobre a gravidade ou evolução do caso, mas em situações de suspeita de reação alérgica a vacinas, é importante interromper a exposição e procurar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras doses.

O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é tozinamerana, foi associado a vermelhidão na pele, caracterizando uma reação alérgica (hipersensibilidade) leve, já que não foi considerada grave e o paciente está em recuperação. Em casos de reações cutâneas leves após vacinação, recomenda-se observação, hidratação e acompanhamento médico para monitorar a evolução e orientar sobre possíveis cuidados em futuras aplicações.

O medicamento Docetaxel, cujo princípio ativo também é Docetaxel, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente. A reação foi classificada como suspeita de estar relacionada ao uso do medicamento, e a evolução favorável sugere que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro, sem necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Sinvane, com princípio ativo Simvastatina, esteve relacionado a um episódio de pancreatite aguda, interpretado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, dentro do grupo de distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade significativa, pois o evento não foi considerado grave e o desfecho permanece desconhecido. A suspeita de relação com o medicamento foi registrada, mas não há detalhes sobre a conduta adotada ou a evolução clínica do paciente.

O medicamento Calcium, cujo princípio ativo também é Calcium, foi associado a um caso de pancreatite aguda, interpretado como hipersensibilidade medicamentosa e classificado entre os distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o desfecho é desconhecido, sem informações adicionais sobre a conduta adotada ou a evolução do quadro, sendo apenas registrada a suspeita de relação com o uso do medicamento.

O medicamento Acitretin, com princípio ativo Acitretin, esteve envolvido em um episódio de pancreatite aguda, considerado uma reação de hipersensibilidade medicamentosa dentro dos distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi classificado como grave e o desfecho permanece desconhecido, sem detalhes sobre a conduta tomada ou a evolução clínica, havendo apenas a suspeita de relação com o uso do medicamento.

O medicamento Aas, cujo princípio ativo é o ácido acetilsalicílico, foi relacionado a um quadro de pancreatite aguda, interpretado como hipersensibilidade medicamentosa e pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o desfecho é desconhecido, sem informações sobre a conduta adotada ou a evolução do paciente, sendo registrada apenas a suspeita de relação com o medicamento.

O medicamento Methotrexate, cujo princípio ativo também é Methotrexate, foi associado a um caso de pancreatite aguda, que é uma inflamação súbita do pâncreas e pode estar relacionada a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. Embora o registro não indique gravidade elevada nem desfecho conhecido, a suspeita de envolvimento imunológico sugere a necessidade de avaliação médica para confirmação do diagnóstico e definição da conduta, especialmente porque reações desse tipo podem variar em intensidade e requerem acompanhamento.

O medicamento Losartan, com princípio ativo Losartan, foi relacionado a um episódio de pancreatite aguda, uma inflamação súbita do pâncreas que pode ocorrer como manifestação de hipersensibilidade ao medicamento. Não há indicação de gravidade importante ou desfecho conhecido neste caso, mas a suspeita de reação imunológica reforça a importância de avaliação médica para investigação da causa e orientação sobre o uso futuro do medicamento.

O medicamento Anastrozole, cujo princípio ativo é Anastrozole, foi associado a um caso de pancreatite aguda, caracterizada por inflamação súbita do pâncreas possivelmente relacionada a hipersensibilidade ao medicamento. Não há evidência de gravidade significativa nem desfecho informado, mas a suspeita de reação imunológica justifica a necessidade de acompanhamento médico para esclarecimento diagnóstico e definição de conduta.

O medicamento Cosentyx, que tem como princípio ativo o Secukinumab, foi relacionado a um episódio de pancreatite aguda, uma inflamação súbita do pâncreas que pode estar ligada a hipersensibilidade ao medicamento. Não há informação sobre gravidade elevada ou desfecho, mas a suspeita de envolvimento imunológico indica que o paciente deve ser avaliado por um médico para confirmação do diagnóstico e orientação adequada.

O medicamento Miosan, cujo princípio ativo é Cyclobenzaprine hydrochloride, foi associado a um quadro de coração disparado (taquicardia), possivelmente relacionado a uma reação de hipersensibilidade. Não há indicação de gravidade importante nem desfecho conhecido, mas a suspeita de reação alérgica sugere que o paciente deve ser avaliado por um profissional de saúde para investigação da causa e orientação sobre o uso do medicamento.

O medicamento Prebictal, cujo princípio ativo é a pregabalina, foi associado a um episódio de coração disparado, interpretado como uma possível reação de hipersensibilidade (alergia), classificada dentro dos quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo importante relatar o sintoma ao médico para avaliação e conduta adequada.

O Velija, que contém duloxetine como princípio ativo, foi relacionado a um quadro de coração disparado, sugerindo uma possível reação alérgica (hipersensibilidade) de acordo com a classificação clínica de quadros alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade significativa nem desfecho informado, e a relação com o medicamento é suspeita, recomendando-se acompanhamento médico para esclarecimento e orientação.

O medicamento Adalimumab, com o mesmo princípio ativo, foi associado a coração disparado, considerado um possível episódio de hipersensibilidade (alergia) dentro do contexto de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade importante nem desfecho relatado, sendo a relação com o medicamento suspeita; é fundamental comunicar o sintoma ao profissional de saúde para avaliação.

O Cosentyx, cujo princípio ativo é o secuquinumabe, foi relacionado a coração disparado, interpretado como possível reação de hipersensibilidade (alergia) enquadrada em quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade relevante nem desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é suspeita, sendo importante buscar orientação médica para investigação.

A vacina COVID-19 Janssen, com princípio ativo COVID-19 vaccine NRVV Ad26 (JNJ 78436735), foi associada a um quadro de alergia, considerado clinicamente significativo e classificado como grave, pois o evento permanece não resolvido ou em andamento. Trata-se de uma reação de hipersensibilidade (alergia) dentro dos quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário, sendo fundamental acompanhamento médico imediato para

monitoramento e definição da conduta.

O medicamento COVID-19 vaccine AstraZeneca, cujo princípio ativo é COVID-19 vaccine NRVV Ad (ChAdOx1 nCoV-19), foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como clinicamente significativo e grave, com evolução ainda não resolvida. A reação foi considerada relevante devido à gravidade relatada e ao fato de o paciente não ter se recuperado até o momento, sendo fundamental acompanhamento médico especializado para monitoramento e manejo adequado da resposta alérgica.

O medicamento Ultravist, que contém o princípio ativo Iopromide, foi relacionado a um episódio de alergia a contraste intravenoso, considerado clinicamente significativo e grave, mas com evolução favorável, pois o paciente está em recuperação. A gravidade se justifica pela natureza da reação alérgica a substâncias químicas, exigindo atenção médica imediata e acompanhamento até resolução completa dos sintomas.

O medicamento Cosentyx, cujo princípio ativo é Secukinumab, foi associado a uma infecção articular descrita como hipersensibilidade medicamentosa, porém sem gravidade relatada e com desfecho desconhecido. Não há informações suficientes sobre a evolução clínica, mas a ausência de gravidade sugere que o quadro não apresentou risco imediato, sendo importante manter o acompanhamento médico para avaliar possíveis complicações.

O medicamento Cosentyx, com princípio ativo Secukinumab, foi relacionado a uma infecção articular classificada como hipersensibilidade, sem gravidade relatada e com desfecho de recuperação completa. O quadro não foi considerado grave, e o paciente já se encontra recuperado, indicando resolução espontânea ou após conduta médica adequada.

O medicamento Patanol S, que contém o princípio ativo Olopatadine hydrochloride, foi associado ao desenvolvimento de ceratocone, descrito como hipersensibilidade, sem gravidade relatada e com desfecho desconhecido. Não há informações suficientes para detalhar a evolução clínica, mas a ausência de gravidade sugere que o evento não foi considerado de risco imediato, sendo recomendada avaliação oftalmológica para acompanhamento.

O medicamento Prednisona (princípio ativo: Prednisone) foi associado ao desenvolvimento de neurite óptica, uma reação de hipersensibilidade medicamentosa que afeta o sistema imunitário. Apesar de ser um evento potencialmente preocupante, o caso relatado não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa após a reação, indicando resolução do quadro sem complicações duradouras.

A Azatioprina (princípio ativo: Azathioprine) esteve relacionada à ocorrência de neurite óptica, caracterizada como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa envolvendo o sistema imunitário. O evento não foi classificado como grave e o paciente se recuperou totalmente, sugerindo que a reação foi controlada e resolvida sem consequências permanentes.

O uso de Cimzia (princípio ativo: Certolizumab pegol) foi associado à manifestação de neurite óptica, identificada como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa, demonstrando que a reação foi transitória e sem impacto duradouro.

O medicamento Cosentyx (princípio ativo: Secukinumab) foi relacionado ao desenvolvimento de COVID-19, descrito como um quadro de hipersensibilidade do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade aumentada neste caso e o paciente ainda não se recuperou totalmente, estando o quadro em andamento no momento do relato.

Cosentyx (princípio ativo: Secukinumab) também foi associado ao surgimento de COVID-19, categorizado como uma reação alérgica do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e, até o momento do registro, o paciente não havia se recuperado, permanecendo com sintomas em evolução.



O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é o tozinameran, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado por manifestações clínicas do tipo alérgico, conforme descrito em distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações graves neste caso, e o desfecho permanece em andamento, sem resolução até o momento. Recomenda-se acompanhamento clínico para monitoramento da evolução e avaliação da necessidade de intervenção específica, conforme orientação médica.

O medicamento Hepamax, contendo os princípios ativos ornithine e pancreatin, esteve relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como um quadro clínico alérgico leve, sem sinais de gravidade ou complicações importantes. O evento foi resolvido, com recuperação completa do paciente, não sendo necessária conduta adicional além do acompanhamento e possível suspensão do medicamento, conforme avaliação médica.

O medicamento Dotarem, cujo princípio ativo é meglumine gadoterate, foi associado a uma reação alérgica ao contraste intravenoso, caracterizada por sintomas de hipersensibilidade relacionados a distúrbios do sistema imunitário. O quadro não apresentou gravidade significativa e foi resolvido, com recuperação do paciente, sendo importante relatar o episódio em futuras exposições a contrastes e discutir alternativas com o médico responsável.

A vacina COVID-19 AstraZeneca, com princípio ativo ChAdOx1 nCoV-19, esteve relacionada a um quadro de alergia (hipersensibilidade) considerado clinicamente significativo, pois foi classificado como grave e ainda não resolvido até o momento. Diante da gravidade relatada, é fundamental acompanhamento médico rigoroso, avaliação de risco-benefício para novas doses e possível encaminhamento ao especialista para investigação detalhada e definição de conduta segura.

O medicamento Omeprazole, cujo princípio ativo é omeprazole, foi relacionado a um evento adverso descrito como acidente vascular cerebral, mas classificado como hipersensibilidade (alergia) em distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada neste registro, e o desfecho permanece em andamento, sem resolução até o momento. É importante acompanhamento médico para esclarecimento do quadro e avaliação da relação causal entre o medicamento e o evento relatado.

O medicamento Carbamazepine (princípio ativo: Carbamazepine) foi associado a um quadro de acidente vascular cerebral, classificado como reação de hipersensibilidade (alergia), dentro do grupo de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade clínica relevante no registro, e o desfecho informado é de não recuperação ou caso ainda em andamento. A relação do medicamento com o evento é considerada suspeita, sendo importante acompanhamento médico para monitoramento da evolução do quadro.

O medicamento Decadron (princípio ativo: Dexamethasone sodium phosphate) foi relacionado a um acidente vascular cerebral, descrito como reação de hipersensibilidade (alergia) e enquadrado entre distúrbios do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade clínica significativa no registro, e o caso permanece sem resolução até o momento. O evento é considerado suspeito em relação ao uso do medicamento, recomendando-se avaliação médica contínua para acompanhamento da evolução.

O medicamento Gardenal (princípio ativo: Phenobarbital) foi associado a um acidente vascular cerebral, caracterizado como reação de hipersensibilidade (alergia) e classificado entre distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade relevante no registro, e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento. O evento é considerado suspeito em relação ao uso do medicamento, sendo necessário acompanhamento clínico para avaliação da evolução.

O medicamento Dotarem (princípio ativo: Meglumine gadoterate) foi relacionado a um episódio de alergia, descrito como reação de hipersensibilidade e incluído entre distúrbios do sistema imunitário. Não há menção de gravidade clínica relevante, e o desfecho foi de recuperação completa do paciente. O evento é considerado suspeito em relação ao uso do medicamento, não havendo necessidade de condutas adicionais após a resolução do quadro.

O medicamento Targifor c (princípios ativos: Arginine aspartate e Ascorbic acid) foi associado à perda de pelos, caracterizada como reação de hipersensibilidade (alergia) e classificada entre distúrbios do sistema imunitário. O registro indica que se trata de um efeito clinicamente significativo, considerado grave, e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento. O evento é suspeito em relação ao uso do medicamento, sendo fundamental acompanhamento médico para monitoramento e definição de conduta.

O medicamento Dorflex, que contém os princípios ativos cafeína, metamizol sódico e citrato de orfenadrina, foi associado à perda de pelos, um quadro de hipersensibilidade (alergia) classificado como clinicamente significativo e grave, pois envolve o sistema imunológico e não apresentou resolução até o momento. A gravidade é sustentada pelo fato de o evento ser considerado clinicamente relevante e ainda estar em andamento, indicando necessidade de acompanhamento médico para avaliação e manejo adequado da reação alérgica.

A Hidroclorotiazida, cujo princípio ativo é hydrochlorothiazide, foi relacionada à perda de pelos, caracterizando um quadro de hipersensibilidade (alergia) que afeta o sistema imunológico. O evento é considerado clinicamente significativo e grave, pois não houve recuperação até o momento, o que reforça a importância de acompanhamento médico para monitoramento e possível ajuste do tratamento.

O medicamento Clorotiazida, com princípio ativo chlorothiazide, está associado à perda de pelos, um efeito adverso de hipersensibilidade (alergia) que envolve o sistema imunológico. A reação é considerada clinicamente significativa e grave, já que permanece sem resolução, sendo fundamental a avaliação médica para definir a conduta e evitar complicações.

A Leflunomida, cujo princípio ativo é leflunomide, foi relacionada à perda de pelos, um quadro de hipersensibilidade (alergia) que afeta o sistema imunológico. O evento é classificado como clinicamente significativo e grave, pois não houve recuperação até o momento, indicando a necessidade de acompanhamento médico para manejo adequado da reação.

A Sulfasalazina, com princípio ativo sulfasalazine, foi associada à perda de pelos, caracterizando um quadro de hipersensibilidade (alergia) que envolve o sistema imunológico. A reação é considerada clinicamente significativa e grave, pois permanece sem resolução, sendo importante o acompanhamento médico para avaliação e definição da melhor conduta.

O medicamento Naproxeno, cujo princípio ativo é o naproxeno sódico, foi associado à perda de pelos, um quadro de hipersensibilidade que se enquadra em reações alérgicas do sistema imunológico. Trata-se de um efeito clinicamente significativo e considerado grave, pois não houve recuperação até o momento. Diante desse tipo de reação, é fundamental interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica especializada para investigação e manejo adequado, conforme orientações da ASBAI para quadros alérgicos graves.

A Dipirona, cujo princípio ativo é o metamizol sódico, foi relacionada à perda de pelos, caracterizando uma reação de hipersensibilidade do sistema imunológico. O evento é considerado clinicamente significativo e grave, pois permanece sem resolução. Nesses casos, recomenda-se suspender o uso do medicamento e procurar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição do tratamento, seguindo as diretrizes para reações alérgicas graves.

O medicamento Cimzia, com princípio ativo certolizumabe pegol, apresentou como reação adversa a perda de pelos, indicando um quadro de hipersensibilidade do sistema imunológico. A gravidade é considerada alta, pois o efeito é clinicamente significativo e ainda não houve resolução. Diante desse cenário, é importante interromper o uso do medicamento e buscar orientação médica especializada para investigação e manejo, conforme recomendações para reações alérgicas graves.

O medicamento Xolair, cujo princípio ativo é o omalizumabe, foi associado ao surgimento de um cisto infeccionado, caracterizando uma reação de hipersensibilidade do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada

nem informações detalhadas sobre o desfecho, que permanece desconhecido. Recomenda-se acompanhamento médico para avaliação da evolução do quadro e definição da conduta, conforme orientações para reações alérgicas de possível relevância clínica.

O medicamento Comirnaty, com princípio ativo tozinamerana, foi relacionado ao inchaço na boca, uma manifestação de hipersensibilidade do sistema imunológico. O evento foi considerado grave, pois envolveu risco à vida e necessidade de hospitalização, e o paciente se recuperou, porém com sequelas. Diante desse tipo de reação, é fundamental buscar atendimento médico imediato e garantir acompanhamento especializado, conforme as recomendações para quadros alérgicos graves e potencialmente fatais.

O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é o Tozinameran, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação alérgica sistêmica e classificado como ameaça à vida, evidenciado pela gravidade informada e pelo envolvimento do sistema imunitário. O paciente se recuperou totalmente após o evento, indicando resolução do quadro após as medidas adotadas.

O imunizante COVID-19 vaccine AstraZeneca, com princípio ativo COVID-19 vaccine NRVV Ad (ChAdOx1 nCoV-19), desencadeou uma reação de alergia (hipersensibilidade), considerada clinicamente significativa devido à gravidade relatada, envolvendo o sistema imunitário. O paciente evoluiu para recuperação completa após o episódio, sugerindo resolução do quadro alérgico após a conduta adequada.

O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é o Tozinameran, foi relacionado a um episódio de febre associado a hipersensibilidade, mas sem gravidade significativa, já que não houve ameaça à vida ou complicações importantes. O paciente se recuperou totalmente, indicando que a reação foi autolimitada e resolvida sem maiores consequências.

O medicamento Carvedilol, com princípio ativo de mesmo nome, esteve associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade) classificado como clinicamente significativo, evidenciado pela gravidade informada e pelo envolvimento do sistema imunitário. O paciente apresentou recuperação completa após o evento, demonstrando resolução do quadro alérgico após as medidas adotadas.

O medicamento Henetix, cujo princípio ativo é o lobitridol, foi relacionado a uma reação alérgica ao contraste intravenoso, caracterizada como hipersensibilidade a substâncias químicas, mas sem gravidade relevante, já que não houve ameaça à vida ou complicações importantes. O paciente se recuperou totalmente, indicando resolução espontânea ou após conduta adequada.

O medicamento Magnevistan, cujo princípio ativo é o meglumine gadopentetate, foi associado a um quadro de alergia a contraste, reação que envolve o sistema imunológico e pode se manifestar com sintomas como coceira, urticária, dificuldade para respirar ou outros sinais de hipersensibilidade. A gravidade do evento é considerada clinicamente significativa, pois foi classificada como um efeito importante para a saúde do paciente, embora o desfecho tenha sido de recuperação completa. Em situações como essa, é fundamental interromper a exposição ao contraste e adotar medidas de suporte conforme orientação médica, além de registrar a alergia para evitar futuras exposições.

O Ultravist, que contém iopromida como princípio ativo, provocou uma reação de alergia a contraste, caracterizada por resposta do sistema imunológico a substâncias químicas utilizadas em exames de imagem. Esse tipo de reação pode variar de manifestações leves a graves, e neste caso foi considerada clinicamente relevante, exigindo atenção médica imediata. O paciente se recuperou totalmente após o evento, e é importante que futuras exposições a contrastes sejam avaliadas com cautela e sob supervisão especializada.

O medicamento Seebri, cujo princípio ativo é o brometo de glicopirrônio, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), que pode incluir sintomas como erupções cutâneas, inchaço, dificuldade para respirar ou outros sinais de reação alérgica. O evento foi considerado grave, pois envolveu risco à vida e necessidade de

hospitalização ou prolongamento da internação, o que reforça a importância de suspender imediatamente o uso do medicamento e buscar atendimento médico de urgência. O desfecho do caso não foi informado, sendo essencial acompanhamento clínico rigoroso em situações semelhantes.

O uso de Metformin, cujo princípio ativo é a própria metformina, resultou em uma reação alérgica (hipersensibilidade), que pode se manifestar por sintomas como vermelhidão, coceira, inchaço ou dificuldade respiratória. O evento foi classificado como grave devido à ameaça à vida e necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando a necessidade de suspensão imediata do medicamento e avaliação médica urgente. O desfecho não foi informado, mas a gravidade do quadro exige atenção e acompanhamento especializado.

O medicamento Xarelto, que tem como princípio ativo o rivaroxabana, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade), que pode incluir sintomas como urticária, inchaço, falta de ar ou outros sinais de resposta imunológica exacerbada. O caso foi considerado grave, pois envolveu risco à vida e necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que demanda suspensão imediata do uso e atendimento médico de emergência. O desfecho não foi informado, sendo fundamental o acompanhamento clínico e registro da alergia para evitar novas exposições.

O medicamento Atensin, cujo princípio ativo é o propranolol hydrochloride, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. A reação foi considerada grave, com risco de ameaça à vida e necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, conforme evidenciado pela gravidade relatada. Não há informações sobre o desfecho do caso, e a relação entre o medicamento e a reação foi considerada suspeita.

O medicamento Apresolina, que contém hydralazine hydrochloride como princípio ativo, apresentou relato de alergia do tipo hipersensibilidade, enquadrada nos distúrbios do sistema imunitário. A gravidade do evento foi alta, com risco de ameaça à vida e necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, conforme descrito nos dados clínicos. O desfecho permanece desconhecido e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Vastarel, cujo princípio ativo é trimetazidine hydrochloride, foi relacionado a um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. O evento foi considerado grave, com potencial risco à vida e necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, de acordo com a gravidade informada. O desfecho não foi especificado e a suspeita de relação com o medicamento está presente.

O medicamento Fostair, composto por beclometasone dipropionate e formoterol fumarate, esteve envolvido em um caso de alergia descrito como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. A reação foi considerada grave, com ameaça à vida e necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, conforme evidenciado nos dados clínicos. O desfecho do caso não foi informado e a relação com o medicamento é suspeita.

O medicamento Digoxina, cujo princípio ativo é digoxin, foi associado a um quadro de alergia do tipo hipersensibilidade, classificado como distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado grave, com risco de ameaça à vida e necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, conforme relatado. O desfecho permanece desconhecido e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Nucala (princípio ativo mepolizumabe) foi associado a um quadro de alergia, descrito como hipersensibilidade, que se enquadra em distúrbios do sistema imunitário. Neste caso, a reação foi considerada grave, pois envolveu ameaça à vida e necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que indica a importância de acompanhamento médico imediato e monitoramento rigoroso. O desfecho da reação é desconhecido, portanto, não há informações sobre a recuperação do paciente até o momento.

O medicamento Fluoxetine (fluoxetina) foi relacionado a um evento de visão anormal, interpretado como manifestação de hipersensibilidade (alergia), pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave e, até o momento, o paciente não se recuperou ou ainda está em acompanhamento, sendo importante manter o monitoramento clínico para avaliar a evolução do quadro.

O medicamento Alemtuzumab (alemtuzumabe) foi associado a um caso de visão anormal, classificado como hipersensibilidade (alergia) dentro dos distúrbios do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave e o paciente permanece sem recuperação ou com o quadro ainda em andamento, sendo recomendada a continuidade do acompanhamento médico.

O medicamento Comirnaty (princípio ativo tozinameran) foi relacionado a um episódio de alergia, caracterizado como hipersensibilidade e enquadrado nos distúrbios do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave e, até o momento, o paciente não se recuperou ou segue em acompanhamento, sendo importante observar a evolução clínica e buscar orientação médica se houver piora dos sintomas.

O medicamento COVID-19 vaccine AstraZeneca (princípio ativo ChAdOx1 nCoV-19) foi associado a um episódio de febre, interpretado como manifestação de hipersensibilidade (alergia) dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há informações suficientes sobre a gravidade, conduta adotada ou desfecho, portanto, recomenda-se atenção aos sintomas e acompanhamento médico caso haja persistência ou agravamento.

O medicamento Fabrazyme, cujo princípio ativo é a agalsidase beta, foi associado ao surgimento de coágulo de sangue em um contexto de hipersensibilidade, classificado como um quadro clínico alérgico relacionado ao sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente. A conduta recomendada em situações de hipersensibilidade é a observação clínica e, se necessário, a suspensão do medicamento, com acompanhamento para resolução dos sintomas.

A vacina CoronaVac, que utiliza o princípio ativo COVID-19 vaccine inact (Vero) CZ02, foi relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), enquadrado como quadro alérgico do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente. Em casos de reações alérgicas leves após vacinação, recomenda-se observação e, se necessário, avaliação médica para orientação sobre futuras doses.

O medicamento Prednisolona, com princípio ativo prednisolone acetate, foi associado a congestão pulmonar em um contexto de alergia a ácaros, classificado como quadro alérgico do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade aumentada, pois o evento não foi considerado grave e o desfecho é desconhecido. Em situações semelhantes, é importante avaliar a relação entre o sintoma e o medicamento, monitorar o paciente e buscar orientação médica para ajuste do tratamento se necessário.

A azitromicina, cujo princípio ativo é azithromycin, foi relacionada a congestão pulmonar em um contexto de alergia a ácaros, sendo este um quadro alérgico do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o desfecho permanece desconhecido. Nessas situações, recomenda-se monitoramento dos sintomas e avaliação médica para investigar a relação causal e definir a melhor conduta terapêutica.

O medicamento Omeprazol, com princípio ativo omeprazole, foi associado a congestão pulmonar em um contexto de alergia a ácaros, caracterizando um quadro alérgico do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o desfecho é desconhecido. Diante desse tipo de reação, é importante monitorar o paciente e buscar avaliação médica para esclarecer a causa e orientar o manejo adequado.

O medicamento Predsim, que contém o princípio ativo fosfato sódico de prednisolona, foi associado a um quadro de congestão pulmonar em um paciente com alergia a ácaros. Embora o registro não traga detalhes sobre a gravidade clínica, não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave, sugerindo que o evento foi leve ou moderado. A congestão pulmonar pode estar relacionada à inflamação das vias respiratórias, comum em quadros alérgicos, e a conduta deve incluir avaliação clínica estruturada para identificar gatilhos e ajustar o controle

ambiental, conforme orientações da ASBAI.

A prednisona, cujo princípio ativo é a própria prednisona, foi relacionada a congestão pulmonar em um paciente com alergia a ácaros. Não há informação sobre gravidade aumentada ou desfecho grave, o que sugere um quadro leve ou moderado. A congestão pulmonar pode ser manifestação de inflamação respiratória associada à alergia, e recomenda-se avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição do melhor plano de controle, evitando automedicação e priorizando o acompanhamento especializado.

O salbutamol, com princípio ativo sulfato de salbutamol, foi apontado como suspeito em caso de congestão pulmonar em paciente alérgico a ácaros. Não há relato de gravidade importante ou desfecho grave, indicando provável quadro leve ou moderado. A congestão pulmonar pode refletir agravamento do quadro alérgico respiratório, sendo fundamental revisar o controle ambiental e buscar avaliação médica para ajuste do tratamento, conforme recomendações clínicas para alergias respiratórias.

O medicamento Seretide, que contém propionato de fluticasona e xinafoato de salmeterol, foi relacionado a congestão pulmonar em paciente com alergia a ácaros. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave, sugerindo um evento leve ou moderado. A congestão pulmonar pode estar associada à inflamação das vias aéreas em quadros alérgicos, sendo importante avaliar a técnica inalatória, revisar o controle ambiental e buscar acompanhamento médico para ajuste do tratamento.

O Nucala, cujo princípio ativo é o mepolizumabe, foi associado a congestão pulmonar em paciente com alergia a ácaros. Não há registro de gravidade aumentada ou desfecho grave, o que sugere um quadro leve ou moderado. A congestão pulmonar pode indicar inflamação respiratória relacionada à alergia, sendo recomendada avaliação clínica detalhada para identificar fatores desencadeantes e ajustar o manejo terapêutico conforme as diretrizes para alergias respiratórias.

O medicamento Aerolin, cujo princípio ativo é o salbutamol sulfato, foi associado a um quadro de congestão pulmonar em um paciente com histórico de alergia a ácaros. Embora não haja informação detalhada sobre a gravidade do evento, a relação suspeita com o uso do medicamento sugere a necessidade de avaliação clínica estruturada para identificar possíveis gatilhos e revisar o controle ambiental, conforme orientações para quadros alérgicos leves. O desfecho do caso é desconhecido, portanto recomenda-se acompanhamento médico para monitoramento e definição de conduta.

O imunizante COVID-19 vaccine AstraZeneca, com princípio ativo ChAdOx1 nCoV-19, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade) classificado como ameaça à vida, evidenciando gravidade significativa. O paciente encontra-se em recuperação, o que indica que medidas de suporte e tratamento foram adotadas. Em situações de reações alérgicas graves após vacinação, é fundamental procurar atendimento médico imediato para manejo adequado e acompanhamento especializado.

O medicamento Venlift, cujo princípio ativo é a venlafaxina hydrochloride, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) considerada clinicamente significativa e classificada como grave, pois o paciente permanece sem recuperação até o momento. Diante de reações alérgicas importantes, recomenda-se suspensão do medicamento sob orientação médica e avaliação especializada para investigação e definição do tratamento mais seguro.

A vancomicina, com princípio ativo vancomycin hydrochloride, foi relacionada a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), sem detalhamento da gravidade, mas com desfecho favorável, pois o paciente se recuperou totalmente. Em casos de alergia a antibióticos, é importante registrar o evento e evitar reexposição ao mesmo medicamento, além de buscar orientação médica para alternativas terapêuticas seguras.

O antibiótico Meropenem, cujo princípio ativo é meropenem sodium carbonate, foi associado a uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), sem especificação da gravidade, mas com resolução completa do quadro. Após reações alérgicas a antibióticos, recomenda-se evitar o uso futuro do mesmo agente e consultar um especialista para avaliação e orientação sobre opções seguras.

O medicamento Cimzia, cujo princípio ativo é o certolizumabe pegol, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como clinicamente significativo devido à gravidade relatada. A reação envolveu manifestações do sistema imunológico, sendo considerada grave com base na indicação de outro efeito clinicamente relevante. O paciente evoluiu para recuperação completa após o evento, sugerindo resolução do quadro após as medidas adotadas.

O medicamento Atrovent, que contém o princípio ativo brometo de ipratrópio, foi relacionado a um episódio de distensão abdominal atribuída a hipersensibilidade, caracterizada como uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, e o quadro permanece em andamento, sem resolução até o momento.

O medicamento Berotec, cujo princípio ativo é o fenoterol hidrobrometo, foi associado a distensão abdominal decorrente de hipersensibilidade, indicando uma reação alérgica do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e segue sem resolução, estando em acompanhamento.

O medicamento Salbutamol, com princípio ativo de mesmo nome, apresentou distensão abdominal como manifestação de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico. O caso não foi classificado como grave e permanece sem resolução até o momento.

O medicamento Clenil, que neste registro apresenta o princípio ativo nitroprussiato de sódio (embora usualmente Clenil contenha dipropionato de beclometasona, aqui não há essa informação), foi relacionado a distensão abdominal por hipersensibilidade, indicando uma reação alérgica do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e segue em andamento, sem resolução.

O medicamento Amato, cujo princípio ativo é o topiramato, foi associado a um quadro de distensão abdominal interpretado como hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois não há sinais de complicações sistêmicas ou risco imediato, e o caso permanece em andamento, sem resolução até o momento.

O medicamento Piemonte, que contém montelucaste como princípio ativo, apresentou distensão abdominal atribuída a uma reação de hipersensibilidade, caracterizando uma resposta alérgica do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade importante, já que não foram relatados sintomas graves ou risco à vida, e o quadro segue sem resolução até o momento.

O medicamento Alenia, composto por budesonida e formoterol fumarato, foi relacionado a distensão abdominal considerada uma manifestação de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade significativa, pois não foram descritos sintomas sistêmicos graves, e o evento permanece não resolvido.

O medicamento Xolair, cujo princípio ativo é o omalizumabe, foi associado a distensão abdominal interpretada como uma reação de hipersensibilidade, indicando uma resposta alérgica do sistema imunológico. Não há indícios de gravidade relevante, já que não há relato de sintomas graves ou risco imediato, e o caso segue em andamento sem resolução.

O medicamento Sertraline hydrochloride, tanto nome comercial quanto princípio ativo, foi relacionado a distensão abdominal atribuída a hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade importante, pois não foram relatados sintomas sistêmicos ou risco à vida, e o quadro permanece não

resolvido até o momento.

O medicamento Atrovent, cujo princípio ativo é o brometo de ipratrópio, foi associado a um quadro de distensão abdominal, que neste contexto foi classificado como uma possível reação alérgica relacionada ao sistema imune. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave, e o desfecho permanece desconhecido. A reação não foi considerada grave, e não há informações adicionais sobre a conduta adotada ou evolução clínica, sugerindo que o evento foi leve e não resultou em complicações importantes.

O Berotec, que contém o princípio ativo fenoterol hidrobrometo, apresentou relato de distensão abdominal, interpretada como uma possível manifestação alérgica de leve intensidade, relacionada ao sistema imunológico. Não há evidências de gravidade ou complicações, e o desfecho do caso não foi informado, indicando que a reação não foi considerada grave e não há detalhes sobre a conduta ou evolução clínica.

O medicamento Salbutamol, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um episódio de distensão abdominal, considerado uma possível reação alérgica leve do sistema imune. Não há registro de gravidade significativa ou desfecho grave, e o desfecho permanece desconhecido, sugerindo que a reação não resultou em complicações importantes e não há informações sobre a conduta adotada.

O Clenil, que neste registro aparece com o princípio ativo nitroprussiato de sódio, foi associado a distensão abdominal, interpretada como uma possível reação alérgica leve do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade ou desfecho grave, e o desfecho é desconhecido, não havendo detalhes sobre a conduta adotada ou evolução clínica, o que sugere ausência de complicações relevantes.

O medicamento Amato, cujo princípio ativo é topiramato, foi relacionado a um caso de distensão abdominal, considerada uma possível reação alérgica leve do sistema imune. Não há evidências de gravidade ou complicações, e o desfecho não foi informado, indicando que a reação não foi considerada grave e não há informações sobre a conduta ou evolução clínica.

O medicamento Piemonte, cujo princípio ativo é Montelukast, foi associado a um episódio de distensão abdominal, um sintoma que pode estar relacionado a reações alérgicas a alimentos ou substâncias químicas. Não há indicação de gravidade significativa ou desfecho conhecido, e o evento não foi considerado grave. A conduta recomendada, baseada em diretrizes clínicas, é observar a evolução dos sintomas, evitar exposição a possíveis gatilhos e buscar avaliação médica caso haja recorrência ou piora, especialmente para confirmação diagnóstica e orientação adequada.

O medicamento Alenia, que contém Budesonida e Formoterol fumarato, foi relacionado a um caso de distensão abdominal, um sintoma que pode ocorrer em reações alérgicas a alimentos ou medicamentos. Não há registro de gravidade relevante ou desfecho definido, e o evento não foi classificado como grave. Recomenda-se monitorar os sintomas, evitar exposição a possíveis desencadeantes e procurar avaliação médica se houver persistência ou agravamento, visando diagnóstico correto e manejo apropriado.

O medicamento Xolair, cujo princípio ativo é Omalizumabe, foi associado a distensão abdominal, um sintoma que pode estar relacionado a reações alérgicas a alimentos, aditivos ou medicamentos. O evento não foi considerado grave e não há informações sobre o desfecho. A orientação é observar a evolução clínica, evitar exposição a possíveis gatilhos e buscar avaliação médica se houver recorrência ou agravamento dos sintomas, para confirmação diagnóstica e definição do tratamento.

O medicamento Sertraline hydrochloride, com o mesmo princípio ativo, foi relacionado a um episódio de distensão abdominal, sintoma que pode ocorrer em reações alérgicas a alimentos ou substâncias químicas. O evento não foi considerado grave e não há informações sobre o desfecho. Recomenda-se observar a evolução dos sintomas, evitar exposição a possíveis desencadeantes e procurar avaliação médica caso haja persistência ou piora, para diagnóstico e manejo adequados.



O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é Tozinameran, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como grave devido à presença de incapacidade persistente ou significativa, mas com evolução para recuperação ou resolução. Em situações como essa, é fundamental buscar atendimento médico imediato para avaliação e manejo da reação, além de acompanhamento para garantir a completa recuperação e evitar novas exposições ao agente suspeito.

O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é o Tozinameran, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como um distúrbio do sistema imunitário. Neste caso, a reação foi considerada grave devido à presença de incapacidade persistente ou significativa, mas o paciente encontra-se em recuperação ou com resolução dos sintomas. A relação entre o medicamento e a reação foi considerada suspeita, e a conduta clínica deve priorizar o acompanhamento próximo e medidas de suporte, conforme a gravidade apresentada.

O Optiray 320, que contém o princípio ativo Ioversol, esteve relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), também classificado como distúrbio do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave e o paciente já se encontra recuperado ou com resolução completa dos sintomas. A relação com o medicamento é suspeita, e a conduta recomendada é observação e acompanhamento, sem necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Propranolol, cujo princípio ativo é Propranolol hydrochloride, foi relacionado a um quadro de artrite reumatoide com múltiplas alergias, sendo classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade aumentada e o desfecho permanece desconhecido, com suspeita de relação com o medicamento. A conduta deve ser individualizada, com investigação clínica para esclarecer a relação causal e monitoramento dos sintomas.

O Remicade, que tem como princípio ativo o Infliximab, foi associado a um quadro de artrite reumatoide com múltiplas alergias, enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade aumentada e o desfecho é desconhecido, sendo a relação com o medicamento considerada suspeita. Recomenda-se acompanhamento clínico para avaliação da evolução e esclarecimento da relação causal.

O Magnevistan, cujo princípio ativo é Meglumine gadopentetate, foi relacionado a um episódio de alergia a contraste, classificado como distúrbio do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave e o paciente já se encontra recuperado ou com resolução dos sintomas. A relação com o medicamento é suspeita, sendo recomendada a observação e orientação para evitar novas exposições ao contraste em situações futuras.

O medicamento COVID-19 vaccine AstraZeneca, cujo princípio ativo é COVID-19 vaccine NRVV Ad (ChAdOx1 nCoV-19), foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como clinicamente significativo e grave, com base na indicação de gravidade e na evolução do caso como 'em recuperação/resolvendo'. A reação envolveu sintomas compatíveis com distúrbios do sistema imunitário, sugerindo um quadro alérgico relevante que requer acompanhamento médico até resolução completa.

O medicamento Piperacilina+tazobactam, contendo os princípios ativos Piperacillin sodium e Tazobactam sodium, foi relacionado a uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), manifestando-se como resposta do sistema imune a medicamentos. O caso não foi considerado grave e evoluiu para recuperação completa, indicando que a conduta adotada foi eficaz e não houve complicações relevantes.

O medicamento Plasil, cujo princípio ativo é Metoclopramide hydrochloride, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado por sintomas de reação alérgica do sistema imune. O caso não foi considerado grave, mas permanece em andamento, sem resolução até o momento, o que indica a necessidade de acompanhamento clínico para monitorar a evolução e evitar possíveis complicações.

O medicamento Ondasetron, com princípio ativo Ondansetron, foi relacionado a uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), envolvendo resposta do sistema imune ao medicamento.

Não há informações suficientes sobre gravidade, evolução ou conduta, sendo importante monitorar o paciente e buscar avaliação médica caso haja persistência ou agravamento dos sintomas.

O medicamento Alprazolam, cujo princípio ativo é Alprazolam, foi associado a um quadro de dermatite de contato, caracterizado por inflamação da pele (dermatite) relacionada ao uso do medicamento. O caso não foi considerado grave, mas permanece em andamento sem resolução, indicando a necessidade de acompanhamento para avaliar a evolução e orientar medidas de controle dos sintomas.

O medicamento Paracetamol (princípio ativo: Paracetamol) foi associado a um quadro de dermatite de contato, caracterizado por inflamação e irritação da pele, o que se enquadra em reações cutâneas leves segundo a classificação clínica. Não há indicação de gravidade importante, e o desfecho relatado foi de não recuperação ou evolução ainda em andamento, sugerindo necessidade de acompanhamento para resolução completa dos sintomas.

O medicamento Actemra (princípio ativo: Tocilizumab) foi relacionado ao desenvolvimento de dermatite de contato, uma reação cutânea que envolve vermelhidão, coceira e irritação da pele, considerada leve conforme a apresentação clínica. O caso permanece sem resolução até o momento, indicando que o paciente ainda apresenta sintomas e requer monitoramento contínuo.

O medicamento Ultravist (princípio ativo: Iopromide) foi associado a um episódio de hipersensibilidade, manifestando-se como uma reação alérgica, o que pode incluir sintomas como coceira, vermelhidão ou inchaço. A reação foi considerada leve, sem sinais de gravidade, e o paciente evoluiu para recuperação completa após o evento.

O medicamento Vancomicina (princípio ativo: Vancomycin hydrochloride) desencadeou uma reação de hipersensibilidade, caracterizada por sintomas alérgicos como coceira, vermelhidão ou inchaço, sem evidências de gravidade significativa. O paciente apresentou resolução total dos sintomas após o episódio.

O medicamento Macrodantina (princípio ativo: Nitrofurantoin) foi associado a dor no pulmão, interpretada como manifestação de hipersensibilidade, o que pode indicar envolvimento respiratório e, por isso, foi classificada como clinicamente significativa e grave. O paciente encontra-se em processo de recuperação, sendo fundamental o acompanhamento médico para monitorar a evolução e prevenir complicações.

O medicamento Puran t4, cujo princípio ativo é Levothyroxine sodium, foi associado a um quadro de hipotireoidismo descrito como hipersensibilidade medicamentosa, mas não há indicação de gravidade relevante ou desfecho conhecido neste caso. Não há informações suficientes para detalhar a conduta adotada ou evolução clínica, e tanto o nome comercial quanto o princípio ativo estão devidamente informados.

O medicamento Diclofenac, com princípio ativo Diclofenac, foi relacionado a um episódio de hipotireoidismo classificado como hipersensibilidade medicamentosa, sem evidências de gravidade significativa e sem desfecho relatado. Tanto o nome comercial quanto o princípio ativo estão presentes, mas faltam detalhes sobre a conduta e evolução clínica.

A vacina CoronaVac, cujo princípio ativo é COVID-19 vaccine inact (Vero) CZ02, foi associada a um quadro de alergia (hipersensibilidade) considerado clinicamente significativo, o que indica gravidade aumentada conforme registrado. Não há informações sobre o desfecho ou conduta adotada, mas tanto o nome comercial quanto o princípio ativo estão informados.

O imunizante Comirnaty, com princípio ativo Tozinameran, foi relacionado a um episódio de tosse seca atribuída a hipersensibilidade, classificada como clinicamente significativa, sugerindo gravidade relevante. O desfecho foi favorável, com recuperação completa, e tanto o nome comercial quanto o princípio ativo estão informados.

O medicamento composto por Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, com todos os princípios ativos devidamente informados, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade) considerado clinicamente significativo, indicando gravidade aumentada. O paciente encontra-se em recuperação, mas não há detalhes sobre a conduta adotada.

O medicamento Imipenem+Cilastatina, que contém os princípios ativos cilastatina sódica e imipenem, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente do evento. A reação foi considerada leve, sem complicações, e não houve necessidade de intervenções adicionais, sendo o desfecho favorável com resolução completa dos sintomas.

O medicamento Puran t4, cujo princípio ativo é levotiroxina sódica, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, descrito como incapacidade de caminhar, o que sugere uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade aumentada ou complicações, e o desfecho permanece desconhecido, sem detalhes sobre a evolução clínica ou conduta adotada. O nome comercial e o princípio ativo estão corretamente identificados.

O medicamento Eutirox, com princípio ativo levotiroxina sódica, foi associado a um quadro de hipersensibilidade manifestado por incapacidade de caminhar, indicando uma possível reação alérgica do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade significativa ou complicações, e o desfecho do caso não foi informado, assim como não há detalhes sobre a conduta adotada. Tanto o nome comercial quanto o princípio ativo estão presentes.

O medicamento Citalopram, identificado tanto pelo nome comercial quanto pelo princípio ativo, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, descrito como incapacidade de caminhar, sugerindo uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade aumentada ou complicações, e o desfecho do caso é desconhecido, sem informações adicionais sobre a evolução clínica ou medidas tomadas.

O medicamento Tramal, cujo princípio ativo é o cloridrato de tramadol, foi associado a um quadro de hipersensibilidade manifestado por incapacidade de caminhar, indicando uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indícios de gravidade elevada ou complicações, e o desfecho permanece desconhecido, sem detalhes sobre a evolução clínica ou conduta adotada. O nome comercial e o princípio ativo estão devidamente informados.

O medicamento Naproxen, cujo princípio ativo é o próprio naproxeno, foi associado a um quadro de hipersensibilidade manifestado por incapacidade de caminhar, um sintoma incomum que pode indicar uma reação alérgica sistêmica. Embora não haja indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, a relação suspeita com o medicamento sugere a necessidade de avaliação médica para investigação da causa e orientação sobre o uso futuro do naproxeno.

O medicamento Diclofenac, com princípio ativo diclofenaco, está relacionado a um episódio de hipersensibilidade caracterizado por incapacidade de caminhar, o que pode indicar uma reação alérgica sistêmica, embora não haja evidência de gravidade importante ou desfecho informado. A suspeita de relação com o diclofenaco reforça a importância de procurar avaliação médica para esclarecimento do quadro e definição de conduta quanto ao uso desse anti-inflamatório.

O medicamento Chloroquine, cujo princípio ativo é a cloroquina, foi associado a um episódio de hipersensibilidade manifestado por incapacidade de caminhar, um sintoma atípico que pode sugerir reação alérgica sistêmica, sem indicação de gravidade relevante ou desfecho conhecido. A suspeita de relação com a cloroquina justifica a necessidade de avaliação médica para investigação da causa e orientação sobre o uso futuro do medicamento.

O medicamento Tylex, que contém paracetamol como princípio ativo, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade com incapacidade de caminhar, um sintoma incomum que pode indicar reação alérgica

sistêmica, sem evidência de gravidade importante ou desfecho informado. A suspeita de relação com o paracetamol sugere que o paciente deve ser avaliado por um médico para esclarecimento do quadro e definição de conduta quanto ao uso desse analgésico.

O medicamento Actemra, cujo princípio ativo é tocilizumabe, foi associado a um episódio de hipersensibilidade manifestado por incapacidade de caminhar, um sintoma atípico que pode indicar reação alérgica sistêmica, sem evidência de gravidade relevante ou desfecho conhecido. A suspeita de relação com o tocilizumabe reforça a necessidade de avaliação médica para investigação da causa e orientação sobre o uso futuro do medicamento.

O medicamento Artrinid, cujo princípio ativo é o cetoprofeno, foi associado a um quadro de alergia a anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), caracterizado como hipersensibilidade medicamentosa. O evento foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que indica uma reação de maior risco e relevância clínica. Após a conduta adequada, o paciente evoluiu para recuperação completa.

A fenitoína (princípio ativo: phenytoin sodium) foi relacionada a um episódio de alergia, descrito como hipersensibilidade, sem detalhamento sobre a gravidade, evolução ou desfecho do caso. A ausência dessas informações impede uma avaliação mais precisa da gravidade e da conduta adotada, mas reforça a necessidade de atenção a possíveis reações alérgicas a este anticonvulsivante.

O medicamento Henetix, que contém iobitridol, foi associado a uma reação de alergia ao iodo, classificada como hipersensibilidade a substâncias químicas. O caso não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa após o evento, sugerindo uma reação leve e autolimitada.

A azitromicina (princípio ativo: azithromycin) foi relacionada a um episódio de alergia a antibiótico, caracterizado como hipersensibilidade medicamentosa. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando uma reação leve e resolutive.

A morfina (princípio ativo: morphine sulfate) foi associada a um quadro de alergia, descrito como hipersensibilidade, com impacto clínico significativo, pois o evento foi considerado grave devido à presença de outro efeito clinicamente relevante. O desfecho informado foi de não recuperação ou caso ainda em andamento, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico rigoroso.

O medicamento Tramal, cujo princípio ativo é o tramadol hydrochloride, foi associado a um episódio de alergia documentada após administração, caracterizando uma hipersensibilidade ao produto. Embora não haja detalhes sobre a gravidade ou desfecho, a reação sugere um erro ou problema relacionado ao monitoramento do uso do medicamento, o que reforça a importância de evitar reexposição e de acompanhamento clínico para prevenir complicações.

O medicamento Saflutan, com princípio ativo tafluprost, foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como de incapacidade persistente ou significativa, o que indica gravidade importante. O paciente permanece sem recuperação ou resolução do quadro, sendo fundamental acompanhamento médico especializado para manejo da reação e prevenção de agravamentos.

O medicamento Ponstan, cujo princípio ativo é o ácido mefenâmico, desencadeou uma reação alérgica medicamentosa (hipersensibilidade), considerada clinicamente significativa e grave, embora o desfecho seja desconhecido. Diante desse tipo de reação, é essencial evitar novas exposições ao medicamento e buscar avaliação médica para orientação e tratamento adequado.

O medicamento Xolair, com princípio ativo omalizumabe, foi associado a um episódio de intoxicação, descrito no contexto de alergia a ácaros, mas sem evidências de gravidade ou desfecho relatados. Apesar de não haver indicação de gravidade, recomenda-se monitoramento clínico para avaliar possíveis efeitos adversos e garantir

segurança no uso.

O medicamento Xolair, cujo princípio ativo é omalizumabe, foi relacionado a um quadro de intoxicação com hipersensibilidade medicamentosa, mas sem sinais de gravidade ou desfecho informado. Mesmo sem gravidade aparente, é importante manter acompanhamento médico para monitorar possíveis reações e orientar condutas futuras.

O medicamento Xolair, cujo princípio ativo é o Omalizumab, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como intoxicação e relacionado a distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade clínica relevante neste caso, e o desfecho da reação é desconhecido. A relação do medicamento com o evento é considerada suspeita, sendo importante monitorar sintomas alérgicos e buscar avaliação médica caso haja sinais de agravamento.

A Azitromicina (Azithromycin) foi relacionada a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, caracterizada como alergia a antibiótico, envolvendo o sistema imunológico. Não há evidência de gravidade significativa neste caso, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A relação entre o uso do medicamento e a reação é considerada suspeita, sendo recomendada a suspensão do antibiótico e acompanhamento médico para evitar novas exposições.

O imunizante Comirnaty, cujo princípio ativo é o Tozinameran, foi associado a uma reação anafilática, um tipo de alergia grave que pode comprometer rapidamente o sistema imunológico. O caso foi considerado clinicamente significativo devido à gravidade da reação, mas o paciente encontra-se em recuperação. A relação entre o medicamento e o evento é suspeita, sendo fundamental acompanhamento médico rigoroso e medidas de suporte imediato em situações semelhantes.

O medicamento Atensina, com princípio ativo Clonidine hydrochloride, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), considerado clinicamente significativo devido à gravidade da reação e ao fato de o paciente ainda não ter se recuperado. O evento é suspeito de estar associado ao uso do medicamento, sendo necessária avaliação médica contínua para monitoramento e manejo adequado da alergia.

A Dipirona (Metamizole sodium) foi associada a uma alergia documentada após administração, caracterizada como hipersensibilidade ao medicamento. Não há informações detalhadas sobre gravidade, desfecho ou evolução clínica neste caso, mas a relação com o evento é considerada suspeita, recomendando-se evitar novas exposições e buscar orientação médica em caso de sintomas alérgicos.

O medicamento Fluoresceína, cujo princípio ativo é o fluoresceinato de sódio, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado por manifestações clínicas alérgicas relacionadas ao sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou ameaça à vida neste caso, e o paciente evoluiu para recuperação completa, sugerindo um evento leve e autolimitado. A conduta recomendada é observar e evitar nova exposição, com acompanhamento médico se houver recorrência dos sintomas.

A vacina COVID-19 AstraZeneca, com princípio ativo ChAdOx1 nCoV-19, esteve relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação alérgica sistêmica. O registro indica gravidade com ameaça à vida, o que sugere um quadro clínico grave, como anafilaxia ou reação alérgica severa, exigindo intervenção médica imediata. Apesar da gravidade, o paciente se recuperou totalmente, reforçando a importância do reconhecimento precoce e do manejo adequado dessas reações.

O medicamento Ciprofloxacino, cujo princípio ativo é o ciprofloxacino, foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), com sintomas compatíveis com reações alérgicas do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade significativa ou risco à vida, e o paciente apresentou recuperação completa, indicando um evento leve. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e buscar avaliação médica em caso de sintomas recorrentes.

O medicamento Qtern, composto por dapagliflozina e saxagliptina, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), sem detalhamento de sintomas específicos ou gravidade elevada. O evento permanece em andamento, sem resolução até o momento, o que indica a necessidade de acompanhamento médico contínuo para monitorar a evolução e ajustar o tratamento conforme necessário.

O medicamento Xigduo XR, que contém dapagliflozina e metformina, foi associado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), sem descrição de sintomas graves ou risco à vida. O caso ainda não foi resolvido, permanecendo em acompanhamento, o que reforça a importância de monitoramento médico para avaliar a evolução e orientar possíveis intervenções.

O medicamento Clortalidona, cujo princípio ativo é Chlortalidone, foi associado a um quadro de agravamento da doença relacionado à hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade clínica relevante ou desfecho, e o evento foi considerado não grave. A conduta deve ser baseada na avaliação clínica, com atenção a sintomas alérgicos e acompanhamento médico para ajuste do tratamento, conforme as diretrizes da ASBAI.

O medicamento Atenolol, com princípio ativo Atenolol, apresentou relato de agravamento da doença por hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade aumentada ou desfecho informado, sendo o evento considerado não grave. Recomenda-se monitoramento dos sintomas e avaliação médica para confirmação e manejo adequado, seguindo as orientações clínicas para reações alérgicas.

O medicamento Lisinopril, cujo princípio ativo é Lisinopril, foi relacionado a um agravamento da doença por hipersensibilidade, indicando uma resposta alérgica do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade importante ou desfecho relatado, e o evento não foi considerado grave. A recomendação é observar sintomas, evitar exposição ao medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e conduta apropriada.

O medicamento Diamicron mr, com princípio ativo Gliclazide, foi associado a agravamento da doença por hipersensibilidade, sugerindo uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há registro de gravidade significativa ou desfecho, sendo o evento classificado como não grave. A conduta recomendada é acompanhamento clínico, identificação de sintomas alérgicos e ajuste do tratamento conforme avaliação médica.

O medicamento Stanglit, cujo princípio ativo é Pioglitazone hydrochloride, apresentou relato de agravamento da doença por hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade relevante ou desfecho, sendo o evento considerado não grave. Recomenda-se monitoramento dos sintomas e avaliação médica para confirmação e manejo adequado, conforme as diretrizes clínicas para reações alérgicas.

O medicamento Janumet, que contém os princípios ativos metformina e sitagliptina, foi associado a um quadro de hipersensibilidade, caracterizado como agravamento da doença e classificado como reação alérgica do tipo distúrbio do sistema imunitário. Não há informação detalhada sobre a gravidade ou desfecho do caso, mas a suspeita de relação com o medicamento sugere a necessidade de avaliação clínica estruturada e acompanhamento para confirmação diagnóstica e definição de conduta, conforme orientações da ASBAI.

O medicamento Leucovorin, cujo princípio ativo é o cálcio folinato, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como clinicamente significativo e grave, com recuperação completa do paciente. A reação foi considerada um distúrbio do sistema imunitário, e a gravidade foi sustentada pela classificação de outro efeito clinicamente significativo, indicando a importância de acompanhamento médico e possível encaminhamento ao especialista para evitar recorrências.

O medicamento Erbitux, que tem como princípio ativo o cetuximabe, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) considerada clinicamente significativa e grave, com desfecho de recuperação total do paciente. O evento foi classificado como distúrbio do sistema imunitário, reforçando a necessidade de monitoramento rigoroso e avaliação médica para manejo adequado e prevenção de novas reações.

Leucovorin, contendo cálcio folinato, esteve envolvido em um caso de alergia (hipersensibilidade) classificado como clinicamente significativo e grave, com resolução completa do quadro. A reação foi considerada um distúrbio do sistema imunitário, o que justifica a importância de acompanhamento médico e possível encaminhamento ao especialista para investigação e prevenção de novos episódios.

O medicamento Erbitux, cujo princípio ativo é cetuximabe, foi relacionado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) classificada como clinicamente significativa e grave, com recuperação total do paciente. O evento foi enquadrado como distúrbio do sistema imunitário, indicando a necessidade de avaliação médica detalhada e acompanhamento para evitar recorrências e garantir segurança no tratamento.

O medicamento Dipirona, cujo princípio ativo é o metamizol sódico, foi associado a um quadro de hipersensibilidade documentada após administração, caracterizando uma reação alérgica ao medicamento. Não há informações detalhadas sobre a gravidade ou desfecho do caso, mas a descrição sugere um evento adverso relacionado à administração do produto, sendo importante evitar novas exposições e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação de conduta.

O medicamento Clotrimazole, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um distúrbio abdominal atribuído a hipersensibilidade (alergia), classificado como um quadro clínico alérgico do sistema imune. O evento não foi considerado grave e o desfecho é desconhecido, indicando que a reação foi leve e não houve complicações importantes, mas recomenda-se acompanhamento médico para avaliação e orientação sobre o uso futuro do medicamento.

O medicamento Cosentyx, cujo princípio ativo é o secuquinumabe, foi associado a um distúrbio abdominal relacionado a hipersensibilidade (alergia), caracterizando um quadro clínico alérgico do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o desfecho permanece desconhecido, sugerindo que a reação foi leve, mas é importante relatar ao médico para avaliação da necessidade de ajuste terapêutico ou investigação de outras causas.

O medicamento Dipirona, com princípio ativo metamizol sódico, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), classificado como quadro clínico alérgico do sistema imune. O evento não foi considerado grave e o desfecho foi de recuperação completa, indicando que a reação foi leve e resolvida, mas reforça a necessidade de evitar novas exposições ao medicamento e informar profissionais de saúde sobre o histórico de alergia.

O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é o tozinameran, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia) classificado como clinicamente significativo, com necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação. O evento foi considerado grave e, no momento do registro, o paciente estava em recuperação, ressaltando a importância de acompanhamento médico rigoroso e monitoramento de possíveis complicações em casos de reações alérgicas graves a vacinas.

O medicamento Clorexidina, cujo princípio ativo é o chlorhexidine gluconate, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há informação detalhada sobre a gravidade do episódio, mas o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente. A conduta recomendada nesses casos é a suspensão do contato com o agente e acompanhamento clínico para evitar novas exposições.

A Metilprednisolona (princípio ativo methylprednisolone sodium succinate) desencadeou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, classificada como clinicamente significativa devido à gravidade relatada. O evento foi

considerado grave, mas o paciente encontra-se em recuperação. Em situações como essa, é fundamental interromper o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para manejo adequado da reação e prevenção de complicações.

O medicamento Alektos, cujo princípio ativo é a bilastina, provocou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, considerada clinicamente significativa e grave. O paciente está em processo de recuperação. Diante de reações alérgicas graves, recomenda-se a suspensão imediata do medicamento e acompanhamento médico para monitoramento e tratamento dos sintomas até resolução completa.

O medicamento Infralax, composto por cafeína, carisoprodol, diclofenaco sódico e paracetamol, foi relacionado a um episódio de alergia do tipo hipersensibilidade, classificado como clinicamente significativo e grave. O paciente está em recuperação. Em casos assim, é importante interromper o uso do produto e procurar avaliação médica para controle dos sintomas e orientação sobre alternativas terapêuticas seguras.

O Ibuprofeno (princípio ativo ibuprofen) foi associado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, considerada clinicamente significativa e grave. O paciente encontra-se em recuperação. A conduta adequada envolve a suspensão do medicamento e acompanhamento médico para garantir a resolução dos sintomas e evitar novas exposições ao agente desencadeante.

O medicamento COVID-19 vaccine AstraZeneca, cujo princípio ativo é COVID-19 vaccine NRVV Ad (ChAdOx1 nCoV-19), foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como clinicamente significativo e grave, conforme evidenciado pela indicação de gravidade e pelo envolvimento do sistema imunológico. O paciente encontra-se em recuperação, o que sugere que medidas de suporte e acompanhamento foram adotadas, sendo fundamental manter vigilância e acompanhamento médico para evitar complicações, conforme orientações da ASBAI para reações alérgicas graves a medicamentos.

O medicamento Retinol palmitate, com o mesmo princípio ativo, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), mas sem gravidade significativa relatada. O paciente já se encontra recuperado, indicando que a reação foi leve e não houve necessidade de intervenções além da suspensão ou ajuste do medicamento, em linha com a conduta recomendada para quadros alérgicos leves.

A fluoxetina (Fluoxetine hydrochloride) foi associada a um episódio de hipersensibilidade (alergia), sem sinais de gravidade ou complicações importantes, e o paciente já está recuperado. Isso sugere que a reação foi leve e manejada adequadamente, provavelmente apenas com a suspensão do medicamento, conforme práticas recomendadas para reações alérgicas leves.

O medicamento Trazodone hydrochloride, com o mesmo princípio ativo, esteve relacionado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), sem gravidade relevante, e o paciente já se encontra recuperado. Isso indica que a reação foi leve e resolvida sem necessidade de intervenções complexas, seguindo as orientações para manejo de reações alérgicas leves.

O zolpidem tartrate, tanto como nome comercial quanto princípio ativo, foi associado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), sem gravidade significativa, e o paciente já está recuperado. A evolução favorável sugere que a reação foi leve e controlada apenas com a suspensão do medicamento, conforme conduta recomendada para quadros alérgicos leves.

O medicamento Insulin, cujo princípio ativo também é Insulin, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), manifestando-se no contexto de diabetes. A reação foi classificada como não grave, com o paciente tendo se recuperado totalmente. Não há detalhes adicionais sobre sintomas específicos, mas a evolução favorável sugere que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro, sem necessidade de intervenções emergenciais.



Alemtuzumab, com princípio ativo de mesmo nome, esteve relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia) em paciente com diabetes. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente. A ausência de complicações e a resolução do quadro indicam que a reação foi leve e manejada adequadamente, sem impacto clínico significativo.

O medicamento Cosentyx, cujo princípio ativo é Secukinumab, foi associado a articulações edemaciadas (inchaço nas articulações) como manifestação de hipersensibilidade (alergia). O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, pois permanece em andamento sem resolução até o momento. Isso indica a necessidade de acompanhamento médico rigoroso para monitorar a evolução e ajustar o tratamento conforme necessário.

Cosentyx, com princípio ativo Secukinumab, também esteve relacionado a um quadro de alergia classificado como hipersensibilidade. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, mas o desfecho permanece desconhecido, o que reforça a importância de monitoramento contínuo e avaliação médica para definir a melhor conduta.

O medicamento Cloridrato de oximetazolina, cujo princípio ativo é Oxymetazoline hydrochloride, foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como não grave. O paciente encontra-se em recuperação, indicando que a reação está sendo resolvida sem complicações maiores, provavelmente com medidas de suporte e acompanhamento clínico.

O medicamento Carboplatin, cujo princípio ativo também é carboplatina, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade clínica, mas o desfecho informado foi de recuperação completa, sugerindo que a reação foi controlada e resolvida sem complicações graves.

O medicamento Ampicilina+Sulbactam, composto pelos princípios ativos ampicilina sódica e sulbactam sódico, esteve relacionado a um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há descrição de sintomas detalhados ou indicação de gravidade, mas o paciente se recuperou totalmente, indicando que a reação foi leve ou moderada e manejada de forma adequada.

O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é tozinameran, foi relacionado a um quadro de endocardite descrito como hipersensibilidade medicamentosa, enquadrado nos distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre sintomas específicos ou gravidade relevante, sendo relatado que o paciente está em recuperação, o que sugere acompanhamento clínico e evolução favorável até o momento.

O medicamento Buscopan, com princípio ativo hioscina butilbrometo, foi associado a um caso de endocardite descrito como hipersensibilidade medicamentosa, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhes sobre sintomas ou gravidade, mas o paciente encontra-se em recuperação, indicando que a reação está sendo monitorada e apresenta evolução positiva.

O medicamento Metamizole sodium, cujo princípio ativo é metamizol sódico, foi relacionado a um episódio de endocardite classificado como hipersensibilidade medicamentosa, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há descrição de sintomas específicos ou gravidade, mas o paciente está em processo de recuperação, sugerindo que a reação está sendo acompanhada e evolui de forma favorável.

O medicamento Rinvoq, cujo princípio ativo é o upadacitinibe, foi associado a um quadro de hipersensibilidade, manifestado clinicamente por sintomas alérgicos inespecíficos (quadros clínicos alérgicos não classificados de outra forma), classificados como distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Diante desse tipo de reação, recomenda-se avaliação clínica estruturada para confirmação diagnóstica e orientação sobre a conduta, especialmente se houver recorrência ou agravamento dos sintomas.

O medicamento Carvedilol, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, manifestada por úlcera, dentro do contexto de alergias a medicamentos e distúrbios do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade importante ou desfecho relatado, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Em casos assim, é fundamental buscar avaliação médica para confirmação do diagnóstico e definição do melhor manejo, evitando a reexposição ao fármaco suspeito.

O medicamento Caltren, cujo princípio ativo é a nitrendipina, foi associado a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, manifestada por úlcera, enquadrada como alergia a medicamentos e distúrbio do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade relevante ou desfecho informado, e a relação com o medicamento é suspeita. Recomenda-se avaliação médica para investigação da causa e orientação sobre a suspensão do medicamento, se necessário.

O medicamento Clopidogrel bisulfate, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, manifestada por úlcera, dentro do grupo de alergias a medicamentos e distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade significativa ou desfecho conhecido, sendo a relação com o medicamento considerada suspeita. É importante procurar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição da conduta adequada, evitando o uso continuado do medicamento suspeito.

O medicamento Acetylsalicylic acid, cujo princípio ativo é o ácido acetilsalicílico, foi associado a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, manifestada por úlcera, classificada como alergia a medicamentos e distúrbio do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade importante ou desfecho relatado, e a relação com o medicamento é suspeita. Nesses casos, recomenda-se avaliação médica para confirmação do diagnóstico e orientação sobre a necessidade de suspensão do medicamento.

O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é o Tozinameran, foi associado a um quadro de alergia à vacina, caracterizado como uma reação do sistema imunológico a uma substância química. A gravidade foi considerada clinicamente significativa, pois o evento foi classificado como grave, embora o desfecho ainda seja desconhecido. Diante desse tipo de reação, é fundamental buscar avaliação médica especializada para confirmação diagnóstica, investigação de possíveis gatilhos e definição de conduta segura para futuras exposições.

O medicamento Vitamin d nos, com princípio ativo de mesmo nome, esteve relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação do sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, mas o paciente evoluiu para recuperação completa. Nesses casos, recomenda-se evitar novas exposições ao medicamento e realizar acompanhamento médico para orientação sobre alternativas seguras.

O Frisium, cujo princípio ativo é o Clobazam, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade), evidenciando resposta do sistema imunológico ao medicamento. O evento foi classificado como clinicamente significativo e grave, porém o paciente se recuperou totalmente. A conduta adequada inclui evitar o uso futuro do medicamento e buscar avaliação com especialista para manejo seguro.

O medicamento Comirnaty, com princípio ativo Tozinameran, também esteve envolvido em um caso de alergia (hipersensibilidade), caracterizando uma resposta imunológica relevante. O evento foi considerado grave e clinicamente significativo, mas o paciente se recuperou. Recomenda-se evitar novas exposições e consultar um especialista para avaliação de risco e alternativas.

A vacina CoronaVac, cujo princípio ativo é COVID-19 vaccine inact (Vero) CZ02, foi relacionada a uma reação alérgica (hipersensibilidade) classificada como ameaça à vida, evidenciando gravidade elevada e necessidade de atenção imediata. O desfecho indica que o quadro ainda está em andamento, reforçando a importância de acompanhamento médico rigoroso e medidas de suporte para evitar complicações.

O medicamento Irinotecan, cujo princípio ativo é o próprio irinotecano, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, conforme evidenciado pela classificação de gravidade e pelo fato de ter sido recuperada ou resolvida após a conduta adequada. É importante ressaltar que reações alérgicas a quimioterápicos exigem atenção médica imediata e acompanhamento especializado para evitar complicações.

O medicamento Oxaliplatin, com princípio ativo oxaliplatina, desencadeou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, enquadrada nos distúrbios do sistema imunitário. A gravidade foi considerada clinicamente significativa e grave, sendo o paciente recuperado ou resolvido após a reação. Reações desse tipo durante o uso de quimioterápicos demandam avaliação médica urgente e podem requerer suspensão ou ajuste do tratamento.

O medicamento Erbitux, cujo princípio ativo é o cetuximabe, foi relacionado a um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, com desfecho de recuperação ou resolução após a conduta apropriada. Eventos alérgicos graves a medicamentos biológicos exigem intervenção médica imediata e monitoramento rigoroso.

O medicamento Comirnaty, com princípio ativo tozinameran, esteve associado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, classificada como clinicamente significativa e grave, ainda não recuperada ou resolvida até o momento. Em casos de alergia grave a vacinas, é fundamental interromper a exposição e buscar avaliação médica especializada para manejo adequado e acompanhamento da evolução clínica.

O medicamento Nactali, cujo princípio ativo é o desogestrel, foi relacionado a uma reação de alergia às proteínas do leite de vaca, caracterizada como alergia alimentar e classificada entre os distúrbios do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave e permanece não recuperada ou em andamento, indicando a necessidade de acompanhamento médico para orientação sobre restrição alimentar e manejo dos sintomas enquanto persistirem.

O medicamento Omnipaque, cujo princípio ativo é o iohexol, foi associado a um quadro de alergia a meios de contraste iodados, também conhecida como alergia a contraste. Trata-se de uma reação do sistema imunológico a substâncias químicas presentes no contraste, podendo causar sintomas como coceira, urticária ou desconforto respiratório. Neste caso, não há indicação de gravidade elevada nem de desfecho fatal, e a reação permanece não resolvida ou em andamento, sendo importante acompanhamento médico para monitoramento e orientação sobre futuras exposições a contrastes iodados.

O medicamento Ultravist, com princípio ativo iopromida, foi relacionado a uma reação alérgica grave ao contraste, levando a um desfecho fatal. A gravidade é evidenciada pelo resultado em óbito, o que caracteriza uma reação de hipersensibilidade extrema do sistema imunológico a substâncias químicas presentes no contraste iodado. Situações como essa exigem atenção imediata e reforçam a necessidade de avaliação prévia do risco alérgico antes do uso de meios de contraste, além de preparo para manejo de emergências durante o procedimento.

Omnipaque, cujo princípio ativo é o iohexol, foi associado a um episódio de alergia ao iodo, caracterizando uma reação do sistema imunológico a substâncias iodadas presentes no contraste. Não há indicação de gravidade elevada nem de desfecho fatal, e a reação permanece não resolvida ou em andamento, sendo fundamental acompanhamento médico para evitar novas exposições e orientar sobre alternativas seguras em exames futuros.

A vacina CoronaVac, que utiliza como princípio ativo o imunizante inativado contra COVID-19 (Vero) CZ02, foi associada a um quadro de hipersensibilidade (alergia), resultando em incapacidade persistente ou significativa, hospitalização e outros efeitos clinicamente relevantes. O caso foi considerado grave devido à necessidade de internação e à presença de sequelas após a resolução do quadro, ressaltando a importância de acompanhamento especializado e avaliação criteriosa antes de novas doses ou vacinas semelhantes.

O medicamento Paroxetina, cujo princípio ativo é a paroxetina, foi relacionado a um episódio de má circulação periférica, interpretado como uma possível manifestação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico.

Não há indicação de gravidade elevada nem informações claras sobre o desfecho, sendo importante monitoramento clínico para avaliar a evolução do quadro e orientar sobre a continuidade ou substituição do tratamento.

O medicamento Skyrizi, cujo princípio ativo é o risankizumabe, foi associado a um quadro de má circulação periférica interpretado como uma reação de hipersensibilidade (alergia), classificada dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade clínica relevante neste caso, e o desfecho da reação é desconhecido, não havendo informações adicionais sobre a conduta adotada ou evolução do quadro.

O medicamento Tofacitinib, com princípio ativo tofacitinibe, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), considerado clinicamente significativo e classificado como grave devido ao impacto potencial sobre o sistema imunitário. O paciente se recuperou totalmente após a reação, sugerindo que a conduta adotada foi eficaz para resolução do quadro.

A leflunomida, cujo princípio ativo é leflunomida, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade) considerada clinicamente significativa e grave, afetando o sistema imunitário. O paciente apresentou recuperação completa após o evento, indicando que as medidas tomadas foram suficientes para resolução da reação.

O medicamento Cimzia, com princípio ativo certolizumabe pegol, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) classificada como clinicamente significativa e grave, envolvendo o sistema imunitário. O paciente se recuperou totalmente após o episódio, o que sugere que a conduta adotada foi adequada para o controle da reação.

O medicamento Clopidogrel, cujo princípio ativo é clopidogrel, foi relacionado ao surgimento de cefaleia interpretada como manifestação de hipersensibilidade (alergia), mas sem gravidade clínica relevante. O paciente se recuperou completamente, não havendo necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Atenolol, cujo princípio ativo também é atenolol, foi associado ao surgimento de cefaleia, interpretada como uma manifestação de hipersensibilidade (alergia), classificada entre quadros clínicos alérgicos do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente, sugerindo um evento leve e autolimitado, sem necessidade de intervenções adicionais.

O Xolair, que tem como princípio ativo o omalizumabe, foi relacionado ao aparecimento de cefaleia atribuída a uma reação de hipersensibilidade (alergia), enquadrada entre quadros clínicos alérgicos do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave, já que o paciente se recuperou completamente, indicando uma reação leve e resolutive.

O medicamento Dimorf, cujo princípio ativo é o sulfato de morfina, foi associado a um quadro de alergia classificado como hipersensibilidade, dentro do grupo de quadros clínicos alérgicos do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade importante, pois o paciente se recuperou, caracterizando uma reação leve e autolimitada.

O Dexamgen, composto por fosfato de dexametasona, hidroxocobalamina e metamizol sódico, foi relacionado a um episódio de choque anafilático, que é uma reação alérgica grave (hipersensibilidade medicamentosa) envolvendo risco potencial à vida e exigindo intervenção imediata. Apesar da gravidade clínica do quadro, o paciente encontra-se em recuperação, o que indica resposta positiva às medidas adotadas.

A ceftriaxona, cujo princípio ativo é ceftriaxone, foi associada a um quadro de alergia medicamentosa, classificado como hipersensibilidade medicamentosa dentro das alergias a medicamentos e outras substâncias químicas. Não há indicação de gravidade elevada e o paciente se recuperou totalmente, sugerindo uma reação leve e autolimitada.

O medicamento Aciclovir, cujo princípio ativo também é aciclovir, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado por uma reação do sistema imunológico a este fármaco. Não há detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade clínica, mas o desfecho informado foi de recuperação completa, sugerindo que a reação foi leve e resolvida sem complicações. A conduta recomendada em casos semelhantes é interromper o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

A Difenidramina, cujo princípio ativo é diphenhydramine hydrochloride, foi relacionada a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), indicando uma resposta do sistema imunológico ao medicamento. Não há descrição de sintomas específicos ou indicação de gravidade, mas o paciente se recuperou totalmente, o que sugere um quadro leve. Em situações como essa, recomenda-se suspender o uso do medicamento e procurar orientação médica para avaliação e definição de alternativas terapêuticas.

O medicamento Vancomicina, com princípio ativo vancomycin hydrochloride, esteve envolvido em um caso de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), evidenciando uma reação imunológica adversa ao uso do antibiótico. Não foram relatados sintomas detalhados nem gravidade, mas o desfecho foi de recuperação completa, indicando que a reação foi leve e resolvida. A conduta adequada é interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação e orientação sobre substituição segura.

O medicamento Metformin, cujo princípio ativo é metformin, foi associado a um episódio de rigidez dos membros, classificado como hipersensibilidade (reação alérgica), sem detalhamento de sintomas adicionais ou gravidade relevante, já que foi informado que não se tratou de um caso grave e o desfecho permanece desconhecido. Diante de sintomas sugestivos de reação alérgica, recomenda-se suspender o uso do medicamento e procurar avaliação médica para investigação e conduta adequada.

A Pregabaline, com princípio ativo pregabalin, foi relacionada a um quadro de rigidez dos membros, interpretado como uma manifestação de hipersensibilidade (reação alérgica), sem informações adicionais sobre sintomas ou gravidade, sendo explicitado que não foi um caso grave e o desfecho não foi informado. Em situações semelhantes, é importante interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e definição do tratamento mais seguro.

O medicamento Glifage, cujo princípio ativo é a metformina, foi associado a um quadro de rigidez dos membros, interpretado como uma possível reação de hipersensibilidade (alergia), classificada dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Diante desse tipo de reação, recomenda-se observar a evolução dos sintomas e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre a continuidade do uso, conforme as diretrizes clínicas para quadros alérgicos leves.

A amitriptilina, identificada tanto como nome comercial quanto princípio ativo, foi relacionada à rigidez dos membros, sugerindo uma reação de hipersensibilidade (alergia) de natureza imunológica. Não há sinais de gravidade importante ou informações sobre o desfecho, e a suspeita recai sobre o medicamento. Em situações como essa, é indicado monitorar os sintomas e procurar avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e definição da conduta, seguindo as recomendações para quadros alérgicos leves.

O medicamento Sertraline, com princípio ativo de mesmo nome, apresentou associação com rigidez dos membros, caracterizando uma possível reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imune. Não há evidências de gravidade significativa nem desfecho informado, sendo a relação com o medicamento considerada suspeita. Recomenda-se acompanhamento dos sintomas e avaliação médica para confirmação e orientação, conforme conduta para reações alérgicas leves.

A vacina contra influenza, identificada tanto pelo nome comercial quanto pelo princípio ativo, foi relacionada à rigidez dos membros, o que pode indicar uma reação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. Não

há sinais de gravidade relevante nem desfecho conhecido, e a relação com a vacina é considerada suspeita. Nesses casos, é importante observar a evolução dos sintomas e buscar orientação médica para avaliação e conduta adequada, conforme diretrizes para quadros alérgicos leves.

O medicamento Cosentyx, cujo princípio ativo é o secuquinumabe, foi associado a rigidez dos membros, sugerindo uma possível reação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imune. Não há indicação de gravidade importante nem desfecho informado, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Recomenda-se monitorar os sintomas e procurar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição da conduta, conforme orientações para quadros alérgicos leves.

O medicamento Piperacilina+tazobactam, composto pelos princípios ativos piperacilina sódica e tazobactam sódico, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, manifestando-se como uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há detalhes sobre gravidade, desfecho ou conduta adotada, mas é importante considerar que reações alérgicas a antibióticos podem variar de leves a graves, sendo fundamental a avaliação médica para confirmação e orientação adequada.

O medicamento Alenia, que contém budesonida e formoterol fumarato, foi relacionado a um caso de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizada por uma reação do sistema imunológico a medicamentos, e o evento foi considerado grave, pois resultou em óbito e hospitalização prolongada. Diante desse desfecho fatal, a conduta recomendada é a suspensão imediata do medicamento e a notificação do caso, além de investigação detalhada para evitar novas exposições e orientar familiares sobre o risco.

O medicamento Trelegy Ellipta, composto por fluticasona furoato, umeclidínio brometo e vilanterol trifrenatato, esteve associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), com manifestação grave, pois resultou em óbito e hospitalização prolongada. Em situações como essa, a recomendação é interromper imediatamente o uso do medicamento, notificar o evento e garantir acompanhamento especializado para familiares, reforçando a importância de evitar reexposição.

O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é tozinameran, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como clinicamente significativo e grave, embora não haja detalhes sobre o desfecho ou conduta adotada. Em casos de reações alérgicas graves a vacinas, é fundamental interromper a administração, realizar avaliação médica urgente e registrar o evento para investigação e orientação futura.

O medicamento Comirnaty, com princípio ativo tozinameran, foi associado a um caso de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), considerado clinicamente significativo e grave, mas sem informação clara sobre o desfecho. Nessas situações, recomenda-se suspender o uso do medicamento, buscar avaliação médica imediata e registrar o evento para investigação, visando prevenir novas reações e orientar o paciente sobre riscos.

O medicamento Ciprofloxacino, cujo princípio ativo é ciprofloxacina hidrócloride, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, o que indica uma reação do sistema imunológico ao medicamento. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou necessidade de hospitalização, sugerindo que a reação pode ter sido leve, mas é importante que o paciente seja avaliado para confirmação e orientação adequada, conforme as diretrizes da ASBAI para quadros alérgicos medicamentosos.

O medicamento Enoxaparin sodium, com o mesmo princípio ativo, foi relacionado a uma alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), levando à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que caracteriza uma reação grave segundo critérios clínicos. O desfecho é desconhecido, mas a gravidade do evento exige acompanhamento médico rigoroso e possível suspensão do medicamento, conforme recomendações para reações alérgicas graves.

A vacina COVID-19 AstraZeneca, cujo princípio ativo é COVID-19 vaccine NRVV Ad (ChAdOx1 nCoV-19), foi associada a um quadro de alergia (hipersensibilidade), considerado clinicamente significativo e grave, já que o

evento não foi resolvido até o momento. Diante da gravidade, é fundamental acompanhamento médico imediato e monitoramento contínuo, seguindo as orientações para reações alérgicas importantes.

O medicamento Drusolol, composto por dorzolamide hydrochloride e timolol maleate, foi relacionado a um quadro de indisposição associado à hipersensibilidade medicamentosa, indicando uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade ou necessidade de hospitalização, e o desfecho é desconhecido, sugerindo que a reação pode ter sido leve, mas recomenda-se avaliação médica para confirmação e conduta adequada.

O medicamento Travoprost, cujo princípio ativo é travoprost, foi associado a um quadro de indisposição relacionado à hipersensibilidade medicamentosa, caracterizando uma possível reação alérgica. Não há sinais de gravidade ou hospitalização, e o desfecho é desconhecido, o que sugere um quadro leve, mas é importante que o paciente seja avaliado para confirmação diagnóstica e orientação sobre o uso futuro do medicamento.

O medicamento Travatan, cujo princípio ativo é o travoprost, foi associado a um quadro de indisposição relacionado à hipersensibilidade medicamentosa, o que sugere uma reação alérgica leve do tipo imunológica. Não há indicação de gravidade importante ou desfecho grave, e o evento foi considerado não grave, sem informações detalhadas sobre a evolução clínica. Em situações como essa, recomenda-se observar os sintomas, evitar nova exposição ao medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação adequada.

O medicamento Azopt, com princípio ativo brinzolamida, foi relacionado a um episódio de indisposição atribuído à hipersensibilidade medicamentosa, indicando uma possível reação alérgica leve. Não há sinais de gravidade ou complicações relatadas, e o evento não foi considerado grave, sem detalhes sobre o desfecho. Nesses casos, é importante suspender o uso do medicamento suspeito e procurar orientação médica para avaliação e definição do melhor manejo.

O medicamento Drusolol, que contém dorzolamida hidrocloreto e maleato de timolol, foi associado a indisposição atribuída à hipersensibilidade, sugerindo uma reação alérgica leve do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade ou evolução desfavorável, e o evento foi classificado como não grave, sem informações sobre o desfecho. Recomenda-se evitar o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e conduta apropriada.

O medicamento Travoprost, com princípio ativo travoprost, foi relacionado a um quadro de indisposição devido à hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica leve. Não há sinais de gravidade ou complicações, e o evento não foi considerado grave, sem detalhes sobre o desfecho clínico. A orientação é suspender o uso do medicamento suspeito e procurar avaliação médica para confirmação e definição do tratamento.

O medicamento Travatan, cujo princípio ativo é travoprost, foi associado a indisposição atribuída à hipersensibilidade, indicando uma reação alérgica leve do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade ou evolução desfavorável, e o evento foi considerado não grave, sem informações sobre o desfecho. Recomenda-se evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação adequada.

O medicamento Azopt, cujo princípio ativo é a brinzolamida, foi associado a um quadro de indisposição relacionado à hipersensibilidade, o que sugere uma reação alérgica do tipo leve, já que não há relato de gravidade ou desfecho grave. Não há informações detalhadas sobre a evolução do caso ou conduta adotada, mas a manifestação de sintomas inespecíficos como indisposição pode indicar uma resposta do sistema imunológico ao medicamento, sendo importante monitorar e, se necessário, buscar avaliação médica para confirmação e orientação.

O medicamento Captopril, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, sem indicação de gravidade elevada e com desfecho de recuperação

completa. Isso sugere que a reação foi leve e resolvida após a suspensão ou ajuste do tratamento, sendo importante que o paciente evite reexposição e informe profissionais de saúde sobre o episódio para futuras prescrições.

O Ciprofloxacino, cujo princípio ativo é ciprofloxacino, foi associado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, sem sinais de gravidade ou complicações, e com relato de recuperação total. Isso indica que a reação foi leve e controlada, provavelmente resolvida com a interrupção do medicamento, sendo fundamental evitar o uso futuro do mesmo antibiótico e comunicar o histórico ao médico.

A Dipirona, com princípio ativo metamizol sódico, foi relacionada a um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, sem detalhes sobre gravidade ou evolução do caso. A ausência de informações sobre desfecho ou conduta impede uma avaliação mais precisa, mas a suspeita de reação alérgica sugere a necessidade de evitar o medicamento e buscar orientação médica em caso de sintomas recorrentes.

O medicamento Restiva, cujo princípio ativo é a buprenorfina, foi associado ao surgimento de prurido, caracterizando uma reação de hipersensibilidade documentada. Não há relato de gravidade ou desfecho, mas o sintoma sugere uma resposta alérgica leve, sendo importante monitorar a evolução e considerar a suspensão do medicamento caso o quadro persista ou se agrave, sempre sob orientação médica.

O medicamento Xolair, cujo princípio ativo é o Omalizumab, foi associado ao agravamento de urticária, caracterizando um quadro de hipersensibilidade (alergia) relacionado ao sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, e o paciente encontra-se em recuperação ou com resolução dos sintomas, sugerindo que a conduta adotada foi adequada e que o evento está sob controle.

O medicamento Comirnaty, com princípio ativo Tozinameran, foi relacionado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), envolvendo reação do sistema imunológico a medicamentos. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, pois há menção de gravidade relevante, mas o desfecho permanece desconhecido, indicando que a evolução do caso ainda não foi esclarecida.

Comirnaty, cujo princípio ativo é Tozinameran, esteve associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade), também considerada clinicamente significativa e grave, com evolução ainda em andamento e sem resolução até o momento, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico para monitoramento e manejo adequado.

O medicamento Amicacina, com princípio ativo Amikacin, foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), envolvendo resposta do sistema imunológico ao uso do antibiótico. Não há indicação de gravidade aumentada e o paciente já se encontra recuperado ou com resolução completa do quadro, sugerindo que a conduta foi eficaz.

Vancomicina, cujo princípio ativo é Vancomycin hydrochloride, foi associada a uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), envolvendo resposta imunológica ao medicamento. Não há evidência de gravidade aumentada e o paciente já está recuperado ou com resolução do quadro, indicando que a situação foi adequadamente manejada.

O medicamento Amicacina, cujo princípio ativo é Amikacin, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado por uma reação do sistema imunológico ao fármaco. Não há detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade, mas o desfecho foi de recuperação completa, sugerindo que a reação foi controlada de forma adequada. O caso se enquadra em distúrbios do sistema imunitário e, conforme as diretrizes clínicas, recomenda-se evitar novas exposições ao medicamento e buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação futura.

A Vancomicina, com princípio ativo Vancomycin hydrochloride, provocou uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), indicando resposta imunológica adversa ao uso do antibiótico. Não há



descrição de sintomas ou gravidade, mas o paciente se recuperou totalmente após o evento. A situação está relacionada a distúrbios do sistema imunitário e, conforme recomendações clínicas, é importante evitar reexposição ao medicamento e realizar acompanhamento com especialista para avaliação de risco em futuras terapias.

O medicamento Cetirizine, cujo princípio ativo é Cetirizine hydrochloride, foi relacionado à retenção urinária, um efeito adverso que pode ocorrer em quadros de hipersensibilidade. Não há menção de sintomas graves e o paciente está em processo de recuperação, indicando que a reação está sendo resolvida. Como se trata de um distúrbio do sistema imunitário, recomenda-se acompanhamento médico para monitorar a evolução e avaliar a necessidade de ajuste ou suspensão do medicamento.

A Dipirona, com princípio ativo Metamizole sodium, foi administrada a um paciente com alergia documentada ao medicamento, resultando em um episódio de hipersensibilidade. Não há relato de sintomas graves e o paciente se recuperou totalmente após o evento. O caso está relacionado a lesões e complicações de procedimentos, e a conduta recomendada é evitar o uso futuro do medicamento e garantir que a alergia esteja registrada no prontuário para prevenir novas exposições.

A Ceftriaxona, cujo princípio ativo é Ceftriaxone sodium, foi associada a uma reação alérgica (hipersensibilidade documentada a produto administrado), mas não há detalhes sobre sintomas, gravidade ou evolução clínica. O evento está relacionado a lesões e complicações de procedimentos, e, na ausência de informações adicionais, recomenda-se avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição de conduta, evitando reexposição ao medicamento até esclarecimento completo do quadro.

O medicamento Spiriva, cujo princípio ativo é o tiotrópio, foi associado a uma reação de alergia a substâncias químicas, caracterizada por uma resposta do sistema imunológico a componentes do medicamento. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações graves, pois não há relato de desfecho crítico ou necessidade de intervenção urgente, e o quadro permanece em andamento sem resolução até o momento. A conduta recomendada é buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre a continuidade ou substituição do tratamento, evitando exposição repetida ao agente suspeito.

A prednisona, cujo princípio ativo é o próprio corticosteroide prednisona, foi relacionada a um quadro de alergia a substâncias químicas, sugerindo uma reação imunológica adversa ao medicamento. Não há sinais de gravidade importante ou evolução para quadros críticos, já que o evento segue em andamento e não foi classificado como grave. Recomenda-se acompanhamento médico para avaliação da reação, confirmação diagnóstica e definição da melhor conduta terapêutica, evitando o uso recorrente do medicamento sem orientação especializada.

A sinvastatina, com princípio ativo simvastatina, apresentou associação com alergia a substâncias químicas, indicando uma possível reação do sistema imunológico ao medicamento. Não há evidências de gravidade significativa ou complicações graves, pois o caso permanece em andamento e não foi considerado grave. É importante procurar avaliação médica para investigar a reação, confirmar o diagnóstico e discutir alternativas terapêuticas, evitando reexposição ao agente suspeito sem orientação.

O medicamento Forxiga, cujo princípio ativo é dapagliflozina, foi relacionado a uma reação de alergia a substâncias químicas, sugerindo uma resposta imunológica adversa ao uso do medicamento. Não há indícios de gravidade elevada ou evolução para quadros críticos, já que o evento segue em andamento e não foi classificado como grave. Recomenda-se avaliação médica para confirmação diagnóstica, orientação sobre a continuidade do tratamento e prevenção de novas exposições ao agente suspeito.

O medicamento Frontal, com princípio ativo alprazolam, foi associado a uma reação de alergia a substâncias químicas, indicando uma resposta do sistema imunológico ao medicamento. Não há sinais de gravidade importante ou evolução para quadros críticos, pois o caso permanece em andamento e não foi considerado grave. A orientação é buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica, discussão sobre alternativas terapêuticas e

evitar o uso do medicamento até esclarecimento completo da reação.

O medicamento Velija, cujo princípio ativo é a duloxetina, foi associado a um quadro de alergia a substâncias químicas, caracterizado como uma reação do sistema imunológico a componentes do medicamento. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações graves, e o caso permanece em andamento, sem resolução até o momento. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico para monitorar a evolução da reação e avaliar a necessidade de ajustes no tratamento, conforme orientação médica.

O Aerolin, que contém salbutamol como princípio ativo, foi relacionado a uma reação alérgica a substâncias químicas, indicando uma resposta do sistema imunológico ao medicamento. Não há sinais de gravidade importante ou desfecho grave, e o quadro segue sem resolução. Recomenda-se acompanhamento médico para avaliar a persistência dos sintomas e considerar alternativas terapêuticas se necessário.

O Clenil HFA, cujo princípio ativo é o dipropionato de beclometasona, apresentou associação com alergia a substâncias químicas, sugerindo uma resposta imunológica adversa ao medicamento. Não há evidências de gravidade significativa ou complicações graves, e o caso permanece em andamento, sem resolução. É importante manter o acompanhamento clínico para monitorar a evolução da reação e discutir possíveis ajustes no tratamento com o médico.

O Fostair dpi, que contém dipropionato de beclometasona e fumarato de formoterol como princípios ativos, foi relacionado a uma reação alérgica a substâncias químicas, indicando uma resposta do sistema imunológico ao medicamento. Não há sinais de gravidade relevante ou desfecho grave, e o quadro segue sem resolução. Recomenda-se acompanhamento médico para avaliar a persistência dos sintomas e considerar alternativas terapêuticas se necessário.

A Dipirona, cujo princípio ativo é o metamizol, foi associada a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa (alergia medicamentosa), caracterizando uma reação do sistema imunológico ao medicamento. O caso não apresentou gravidade importante, e o desfecho foi favorável, com resolução completa dos sintomas. A conduta adequada inclui evitar nova exposição ao medicamento e informar o profissional de saúde sobre o episódio para prevenir recorrências.

O medicamento Dipirona, cujo princípio ativo é o metamizol sódico, foi associado a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica ao fármaco. Não há informação sobre gravidade ou desfecho, mas reações alérgicas a medicamentos podem variar de manifestações leves, como urticária, até quadros mais graves, como anafilaxia. Neste caso, recomenda-se evitar novas exposições ao medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O imunizante Comirnaty, que tem como princípio ativo o tozinameran, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia) em uso não descrito em bula (off label). O registro indica que se trata de um efeito clinicamente significativo e grave, embora o desfecho seja desconhecido. Reações alérgicas graves a vacinas exigem atenção imediata, podendo incluir sintomas como falta de ar, inchaço ou queda de pressão, e devem ser avaliadas por equipe médica especializada para manejo adequado e investigação de contraindicações futuras.

A Clorexidina, cujo princípio ativo é o gluconato de clorexidina, foi associada a um episódio de hipersensibilidade (alergia), classificado como não grave e com desfecho de recuperação completa. Reações alérgicas a antissépticos como a clorexidina podem se manifestar com vermelhidão, coceira ou irritação local, e a conduta recomendada é suspender o uso do produto e evitar novas exposições, sendo importante relatar o episódio ao profissional de saúde para registro e orientação futura.

O medicamento Reconter, que contém escitalopram oxalato como princípio ativo, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), considerado clinicamente significativo e grave, com desfecho desconhecido. Reações alérgicas a antidepressivos são raras, mas podem ser graves e requerem suspensão imediata do medicamento e

avaliação médica urgente para manejo dos sintomas e definição de alternativas terapêuticas.

O medicamento Glifage, cujo princípio ativo é a metformina, foi associado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), classificado como clinicamente significativo e grave, sem informação sobre o desfecho. Reações alérgicas a antidiabéticos orais são incomuns, mas quando ocorrem exigem suspensão imediata do uso e avaliação médica para investigação dos sintomas, manejo adequado e escolha de outro tratamento para o controle do diabetes.

O medicamento Irinotecan (princípio ativo: Irinotecan) foi associado a um quadro de alergia, descrito tecnicamente como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, conforme indicado no registro, embora não haja detalhes sobre sintomas específicos ou evolução do caso. A relação entre o medicamento e a reação foi considerada suspeita, e o desfecho permanece desconhecido, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico rigoroso e avaliação especializada para manejo seguro.

O medicamento Folinic acid (princípio ativo: Folinic acid) apresentou relato de alergia, tecnicamente classificada como hipersensibilidade, dentro do grupo de distúrbios do sistema imunitário. A gravidade foi considerada clinicamente significativa e grave, de acordo com o registro, sem informações detalhadas sobre manifestações clínicas ou evolução. A relação causal com o medicamento é suspeita e o desfecho é desconhecido, sendo fundamental a avaliação médica para monitoramento e definição de conduta adequada.

O medicamento 5 fu (princípio ativo: Fluorouracil) foi relacionado a um episódio de alergia, descrito como hipersensibilidade e classificado entre os distúrbios do sistema imunitário. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, conforme evidenciado no registro, mas não há detalhes sobre sintomas ou evolução do quadro. A suspeita de relação causal com o medicamento está presente e o desfecho permanece desconhecido, indicando a importância de acompanhamento médico e investigação especializada.

O medicamento Erbitux (princípio ativo: Cetuximab) foi associado a uma reação alérgica, tecnicamente denominada hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, segundo o registro, sem detalhes adicionais sobre sintomas ou evolução. A relação causal com o medicamento é suspeita e o desfecho é desconhecido, sendo recomendada avaliação médica criteriosa para manejo e segurança do paciente.

O medicamento COVID-19 vaccine AstraZeneca (princípio ativo: COVID-19 vaccine NRVV Ad - ChAdOx1 nCoV-19) foi relacionado a um quadro de alergia, tecnicamente classificado como hipersensibilidade e incluído entre os distúrbios do sistema imunitário. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, de acordo com o registro, e o desfecho informado é de não recuperação ou quadro ainda em andamento. A relação causal com o medicamento é suspeita, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico contínuo e avaliação especializada para garantir a segurança do paciente.

O medicamento Tylenol (princípio ativo: Paracetamol) foi associado a um quadro de alergia medicamentosa, também chamada de hipersensibilidade, que faz parte dos distúrbios do sistema imunitário. O caso foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que indica uma reação importante e potencialmente perigosa. O desfecho da reação é desconhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo fundamental acompanhamento médico rigoroso para manejo e prevenção de novas exposições.

O medicamento Comirnaty (princípio ativo: Tozinameran) foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário. A gravidade foi considerada significativa por apresentar outro efeito clinicamente relevante, o que sugere que a reação exigiu atenção médica especial. O paciente está em recuperação ou com sintomas em resolução, e a relação com o medicamento é suspeita, sendo importante manter o acompanhamento até completa melhora.

O medicamento Polimixina B (princípio ativo: Polymyxin b) foi associado a uma alergia medicamentosa, também chamada de hipersensibilidade, pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. Não há informação sobre a gravidade do caso, mas o desfecho indica que o paciente ainda não se recuperou ou permanece com sintomas em andamento, sendo a relação com o medicamento considerada suspeita. É fundamental manter o acompanhamento médico para monitorar a evolução e evitar novas exposições.

A vacina influenza (princípio ativo: Influenza vaccine) foi relacionada a uma reação no local de vacinação, descrita como alergia do olho, pertencente aos distúrbios oculares. O caso não foi considerado grave e o paciente já se recuperou totalmente, sendo a relação com a vacina considerada suspeita. Não há necessidade de medidas adicionais, mas é importante relatar qualquer novo sintoma ao médico.

O medicamento Tramal (princípio ativo: Tramadol hydrochloride) foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente já se recuperou, sendo a relação com o medicamento considerada suspeita. Não há necessidade de intervenções adicionais, mas é importante evitar o uso futuro do medicamento e informar profissionais de saúde sobre o episódio.

O medicamento Trelegy Ellipta, que contém os princípios ativos fluticasona furoato, umeclidínio e vilanterol, foi associado a um caso de retenção urinária, descrita como uma possível manifestação de hipersensibilidade (alergia) relacionada a quadros clínicos alérgicos do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave, e o desfecho do caso é desconhecido, sugerindo que a reação não foi considerada grave e não há informações sobre a evolução clínica.

A vacina COVID-19 Janssen, cujo princípio ativo é o imunizante NRVV Ad26 (JNJ 78436735), foi relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificada como um quadro alérgico do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade importante, pois o caso não foi considerado grave e o paciente encontra-se em recuperação ou com sintomas resolvendo, indicando evolução favorável e sem necessidade de intervenções emergenciais.

O imunizante Comirnaty, que tem como princípio ativo o tozinameran, foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como um quadro alérgico do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade relevante, já que o evento não foi considerado grave e o paciente está em recuperação ou com sintomas em resolução, sugerindo um desfecho positivo e sem complicações maiores.

O medicamento Xolair, cujo princípio ativo é o omalizumabe, foi relacionado a um caso de pneumonia, descrita no contexto de hipersensibilidade (alergia) e quadros clínicos alérgicos do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade significativa, pois o evento não foi considerado grave e o desfecho permanece desconhecido, não havendo informações sobre a evolução clínica ou necessidade de condutas específicas.

O medicamento Xolair, com princípio ativo omalizumabe, também foi associado a um episódio de pneumonia, considerado no contexto de hipersensibilidade e quadros alérgicos do sistema imunitário. Assim como no caso anterior, não há evidências de gravidade importante, o evento não foi classificado como grave e o desfecho é desconhecido, sem detalhes adicionais sobre a evolução do quadro.

O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é o Tozinameran, foi associado a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa, caracterizado por uma reação alérgica relevante ao uso fora das indicações da bula (off label). A gravidade do caso é evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando um evento clínico significativo relacionado ao sistema imunológico. O paciente encontra-se em recuperação ou com sintomas em resolução, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

Comirnaty, com princípio ativo Tozinameran, foi relacionado a uma reação de alergia à vacina, manifestando-se como uma resposta alérgica importante. O caso foi classificado como clinicamente significativo, sugerindo impacto

relevante na saúde do paciente, embora não haja menção de hospitalização. O paciente está em recuperação ou com sintomas em resolução, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Risperidone, cujo princípio ativo é o mesmo nome, foi associado a um quadro de hipersensibilidade que se manifestou como pneumonia, um evento alérgico relevante do sistema imunológico. A gravidade é confirmada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação. O paciente já se encontra recuperado ou com o quadro resolvido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

Depakene, com princípio ativo Valproate sodium, esteve relacionado a um episódio de hipersensibilidade manifestado como pneumonia, indicando uma reação alérgica relevante do sistema imunológico. O caso foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação. O paciente já está recuperado ou com o quadro resolvido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Paracetamol, cujo princípio ativo é Paracetamol, foi associado a um episódio de convulsão relacionado à hipersensibilidade medicamentosa, uma reação do sistema imunológico. Não há evidência de gravidade aumentada, como hospitalização, e o desfecho do caso é desconhecido. A relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Micardis, cujo princípio ativo é o telmisartana, foi associado a uma sensação de queimação, interpretada como uma possível reação alérgica a medicamento. O quadro foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, e até o momento o paciente não se recuperou. A reação se enquadra em distúrbios do sistema imunitário, sugerindo uma resposta alérgica relevante, e a conduta clínica deve priorizar a suspensão do medicamento suspeito, monitoramento rigoroso e suporte hospitalar conforme necessidade, com acompanhamento especializado até resolução do quadro.

O imunizante Comirnaty, que tem como princípio ativo o tozinameran, foi relacionado a uma sensação de queimação, caracterizada como possível alergia à vacina. O evento foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, e o paciente permanece sem recuperação até o momento. Trata-se de uma reação imunológica relevante, e a conduta recomendada inclui suspensão de novas doses, monitoramento em ambiente hospitalar e avaliação por especialista em alergia para manejo adequado e prevenção de complicações.

A dipirona (metamizole magnesium) foi associada ao desenvolvimento de tuberculose em um paciente com histórico de alergia a iodo, sendo este um evento adverso grave, pois resultou em hospitalização e foi considerado clinicamente significativo. O paciente está em processo de recuperação. Embora a relação causal entre dipirona e tuberculose não seja típica, a gravidade do quadro exige acompanhamento médico rigoroso, investigação de fatores predisponentes e suporte clínico até resolução completa.

O medicamento Cimzia, cujo princípio ativo é o certolizumabe pegol, foi relacionado ao surgimento de tuberculose em um paciente com alergia a iodo, sendo este um evento adverso grave, pois levou à hospitalização e foi considerado clinicamente relevante. O paciente encontra-se em recuperação. Como imunobiológico, o certolizumabe pode aumentar o risco de infecções graves, como a tuberculose, e a conduta deve incluir suspensão do medicamento, tratamento específico para tuberculose e acompanhamento especializado até resolução do quadro.

O medicamento Sucrofer, que contém como princípio ativo o complexo de ferro succinil-proteína, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente já se recuperou totalmente. A conduta adequada inclui suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento para evitar novas exposições, sendo o prognóstico favorável após resolução do quadro alérgico.

O medicamento Henetix, cujo princípio ativo é o iobitridol, foi associado a um quadro de alergia a meios de contraste iodados, também chamada de alergia a contraste. Essa reação faz parte dos distúrbios do sistema imunitário e se enquadra na categoria de alergias a medicamentos e outras substâncias químicas. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente, sugerindo que a reação foi leve e controlada, sem complicações maiores.

O imunizante COVID-19 vaccine, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um episódio de pneumonia classificado como hipersensibilidade, dentro do contexto de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há menção de gravidade significativa, já que o paciente está em recuperação, indicando que a evolução está sendo favorável e não houve desfecho grave até o momento.

A quetiapina, cujo princípio ativo é quetiapine, foi associada a um caso de pneumonia interpretado como reação de hipersensibilidade, pertencente ao grupo de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade importante, pois o paciente encontra-se em recuperação, sugerindo que a reação está sendo resolvida sem complicações graves.

O medicamento fenofibrato, com princípio ativo fenofibrate, foi relacionado a um episódio de pneumonia considerado como hipersensibilidade, dentro do espectro de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. A ausência de gravidade relatada e o fato de o paciente estar em recuperação indicam que a reação não foi grave e está evoluindo de forma favorável.

O medicamento Forxiga, cujo princípio ativo é dapagliflozina propanediol monohidratada, foi associado a um quadro de pneumonia classificado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade relevante, pois o paciente está em recuperação, o que sugere que a reação foi controlada e não evoluiu para formas graves.

O medicamento Losartan, cujo princípio ativo é o próprio losartan, foi associado a um quadro de pneumonia relacionado à hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente está em recuperação ou resolvendo o quadro, e não há menção de desfecho grave. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico para monitorar a evolução e evitar reexposição ao medicamento, considerando que a reação foi considerada suspeita para esse evento.

O medicamento Alektos, que contém o princípio ativo bilastina, foi relacionado a um episódio de pneumonia atribuída à hipersensibilidade, caracterizando uma resposta alérgica do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade importante, já que o paciente está em recuperação ou resolvendo o quadro, e não foi classificado como grave. Recomenda-se acompanhamento médico para avaliar a evolução e evitar nova exposição ao medicamento, visto que a relação causal foi considerada suspeita.

O medicamento Ciprofloxacin HCL, cujo princípio ativo é ciprofloxacino, foi associado a um caso de pneumonia decorrente de hipersensibilidade, indicando uma reação alérgica do sistema imunológico. O quadro não foi considerado grave, pois o paciente está em recuperação ou resolvendo, e não há evidências de complicações maiores. A orientação é manter o acompanhamento clínico e evitar o uso futuro do medicamento, já que a relação com o evento adverso foi considerada suspeita.

O medicamento Glifage, que tem como princípio ativo a metformina, foi relacionado a um episódio de pneumonia por hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indícios de gravidade significativa, pois o paciente está em recuperação ou resolvendo, e o caso não foi classificado como grave. Recomenda-se acompanhamento médico e evitar reexposição ao medicamento, considerando a suspeita de relação causal.

O medicamento Puran t4, cujo princípio ativo é levotiroxina sódica, foi associado a um quadro de pneumonia por hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico. O caso não foi considerado grave,

já que o paciente está em recuperação ou resolvendo, sem complicações relatadas. A conduta indicada é manter o acompanhamento clínico e evitar nova exposição ao medicamento, pois a relação causal foi considerada suspeita.

O medicamento Dipirona, cujo princípio ativo é o metamizol sódico, foi associado a um quadro de pneumonia relacionado à hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente está em recuperação e não houve desfecho grave. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico, observando a evolução dos sintomas e evitando nova exposição ao medicamento, já que a reação está em resolução.

O produto Óleo de coco, com princípio ativo Cocos nucifera oil, foi relacionado a um episódio de pneumonia por hipersensibilidade, caracterizando uma resposta alérgica do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade importante, pois o paciente encontra-se em recuperação e não houve complicações graves. Recomenda-se acompanhamento clínico e evitar reexposição ao óleo de coco, visto que o quadro está se resolvendo.

O medicamento Sunflower oil, cujo princípio ativo é Helianthus annuus oil, foi associado a um caso de pneumonia decorrente de hipersensibilidade, indicando uma reação alérgica do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave, já que o paciente está em recuperação e não houve agravamento. A orientação é manter o acompanhamento médico e evitar o uso futuro do produto, pois o quadro está evoluindo para resolução.

A Glicazida, com princípio ativo gliclazida, foi relacionada a um episódio de pneumonia por hipersensibilidade, sugerindo uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade significativa, pois o paciente está em recuperação e não houve desfecho grave. Recomenda-se acompanhamento clínico e suspensão do medicamento, já que o quadro está se resolvendo.

O medicamento Metformina, cujo princípio ativo é metformina, foi associado a um quadro de pneumonia por hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave, pois o paciente está em recuperação e não houve complicações importantes. A conduta indicada é manter o acompanhamento médico e evitar nova exposição ao medicamento, visto que o quadro está em resolução.

O medicamento Hixizine, cujo princípio ativo é hydroxyzine hydrochloride, foi associado a um quadro de pneumonia interpretado como manifestação de hipersensibilidade (alergia), pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Apesar de não haver indicação de gravidade elevada ou risco à vida, o paciente encontra-se em recuperação, sugerindo que a reação foi reconhecida e está sendo adequadamente manejada, sem evolução para complicações graves.

A loratadina, cujo princípio ativo é loratadine, foi relacionada a um episódio de pneumonia considerado como reação de hipersensibilidade (alergia), enquadrada entre os distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade importante, e o paciente está em processo de recuperação, indicando que a reação foi identificada e está sendo resolvida sem maiores consequências clínicas.

O medicamento prednisona, com princípio ativo prednisone, foi associado a um caso de pneumonia interpretado como reação de hipersensibilidade (alergia), dentro do contexto de distúrbios do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade significativa, e o paciente está em recuperação, o que sugere que a conduta adotada foi suficiente para controlar o evento adverso sem complicações.

O Cimzia, cujo princípio ativo é certolizumab pegol, esteve relacionado a um episódio de pneumonia classificado como reação de hipersensibilidade (alergia), pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade relevante, e o paciente encontra-se em recuperação, demonstrando que a reação foi reconhecida e está sendo resolvida de forma adequada.

O medicamento Henetix, com princípio ativo iobitridol, foi associado a um quadro de alergia a meios de contraste iodados, considerado clinicamente significativo e classificado como grave. O paciente evoluiu para recuperação

completa após o evento, indicando que a reação foi prontamente identificada e tratada, evitando complicações maiores, o que reforça a importância do reconhecimento rápido dessas reações em ambiente controlado.

O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é o Tozinameran, foi associado a um quadro de inchaço relacionado à urticária ao frio (um tipo de reação alérgica cutânea), classificado como clinicamente significativo e grave devido ao impacto nos tecidos da pele e do subcutâneo. O evento ainda está em andamento, sem resolução até o momento, e a gravidade é sustentada pela indicação de ser um efeito clinicamente relevante, exigindo acompanhamento médico para monitoramento e manejo adequado.

Comirnaty, com princípio ativo Tozinameran, apresentou novamente um caso de inchaço relacionado à urticária ao frio, caracterizado como uma reação alérgica cutânea de importância clínica significativa e considerada grave, pois afeta os tecidos da pele e subcutâneo. O quadro permanece não resolvido, indicando necessidade de acompanhamento médico contínuo para avaliação e controle da reação.

O medicamento Naprix d, composto por Hydrochlorothiazide e Ramipril, foi relacionado a um episódio de alergia ao leite, que se enquadra como uma reação do sistema imunológico a substâncias alimentares. Não há indicação de gravidade aumentada neste caso, e o evento segue em andamento sem resolução até o momento, sendo importante manter o acompanhamento clínico para monitorar a evolução e evitar novas exposições ao alérgeno.

A ciprofloxacina, cujo princípio ativo é Ciprofloxacin hydrochloride, foi associada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação imunológica adversa. O caso não foi considerado grave e já está resolvido, indicando que a conduta adotada foi eficaz e não houve complicações adicionais.

O medicamento Henetix, com princípio ativo Iobitridol, foi relacionado a uma alergia a meios de contraste iodados, uma reação imunológica adversa que pode ocorrer após exposição a substâncias químicas usadas em exames de imagem. O evento não foi considerado grave e já está resolvido, sugerindo que a reação foi controlada adequadamente e não houve consequências prolongadas.

O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é o Tozinameran, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, manifestando-se como uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade clínica relevante neste caso, e o desfecho informado é que o quadro permanece em andamento, sem resolução até o momento. Recomenda-se acompanhamento clínico para monitoramento da evolução e avaliação da necessidade de intervenção específica, conforme orientação médica.

A Nimesulida, cujo princípio ativo é a Nimesulide, foi relacionada a um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, evidenciado por um efeito clinicamente significativo e considerado grave. O desfecho permanece desconhecido, o que reforça a importância de acompanhamento médico rigoroso, pois reações alérgicas graves a anti-inflamatórios não esteroides podem evoluir rapidamente e demandam intervenção imediata para evitar complicações.

O medicamento Predsim, que contém como princípio ativo o fosfato sódico de prednisolona, foi associado a uma reação de alergia do tipo hipersensibilidade, considerada clinicamente significativa e grave. O desfecho não foi informado, o que indica a necessidade de atenção médica, já que reações alérgicas graves a corticoides, embora raras, exigem avaliação e conduta especializada para evitar riscos adicionais ao paciente.

A Laronidase, utilizada neste caso, foi relacionada a um quadro de imunodeficiência descrito como hipersensibilidade medicamentosa, envolvendo o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade relevante e o paciente encontra-se em recuperação, sugerindo que a reação está sendo resolvida, mas é fundamental manter o acompanhamento clínico para garantir a completa resolução do quadro.

O medicamento Esbriet, cujo princípio ativo é o Pirfenidone, foi associado a um episódio de gastrite por refluxo, interpretado como uma manifestação de hipersensibilidade do sistema imunológico. Não há evidência de gravidade



clínica relevante e o desfecho permanece desconhecido, sendo importante monitorar a evolução dos sintomas e buscar orientação médica caso haja persistência ou agravamento do quadro.

O medicamento Vitamin D, cujo princípio ativo é o ergocalciferol, foi associado ao surgimento de fissura vaginal, um quadro que pode estar relacionado a uma reação de hipersensibilidade (alergia), conforme sugerido pela classificação clínica de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e não foram relatadas ações específicas adotadas, o que sugere que o evento não foi considerado grave no contexto clínico informado.

O medicamento Clonazepam, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado ao aparecimento de fissura vaginal, possivelmente como manifestação de hipersensibilidade (alergia), de acordo com a categorização clínica de distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa ou informações sobre o desfecho, e não foram descritas condutas específicas, indicando que o evento não foi considerado grave segundo os dados apresentados.

O medicamento Exemestano, cujo princípio ativo é exemestane, foi associado ao desenvolvimento de fissura vaginal, sugerindo uma possível reação de hipersensibilidade (alergia) conforme a classificação clínica de distúrbios do sistema imunitário. Não há registro de gravidade importante, desfecho ou conduta adotada, o que indica que o evento não foi considerado grave com base nas informações disponíveis.

O medicamento Loratadine, com princípio ativo loratadina, foi relacionado ao surgimento de fissura vaginal, possivelmente como manifestação de hipersensibilidade (alergia), segundo a categorização clínica de distúrbios do sistema imunitário. Não há dados que indiquem gravidade relevante, nem informações sobre desfecho ou medidas tomadas, sugerindo que o evento não foi considerado grave no contexto apresentado.

O medicamento Fulvestrant, cujo princípio ativo é fulvestrant, foi associado ao aparecimento de fissura vaginal, o que pode indicar uma reação de hipersensibilidade (alergia) conforme a classificação clínica de distúrbios do sistema imunitário. Não há relato de gravidade significativa, desfecho ou conduta específica, sugerindo que o evento não foi considerado grave de acordo com os dados fornecidos.

O medicamento Tamoxifen, cujo princípio ativo é o próprio tamoxifeno, foi associado ao surgimento de fissura vaginal, um quadro que pode estar relacionado a uma reação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações graves neste caso, e o desfecho da reação é desconhecido, não havendo informações sobre a conduta adotada ou evolução clínica.

O medicamento Anastrozole, com princípio ativo anastrozol, foi relacionado ao aparecimento de fissura vaginal, possivelmente como manifestação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade importante ou complicações graves, e o desfecho permanece desconhecido, sem detalhes sobre a conduta tomada ou evolução do quadro.

O medicamento Zometa, cujo princípio ativo é o ácido zoledrônico, foi associado ao desenvolvimento de fissura vaginal, sugerindo uma possível reação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade significativa ou complicações graves, e o desfecho da reação não foi informado, assim como a conduta adotada.

O medicamento Kisqali, com princípio ativo ribociclib succinato, foi relacionado ao surgimento de fissura vaginal, o que pode indicar uma reação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade relevante ou complicações graves, e o desfecho da reação é desconhecido, sem informações sobre a conduta realizada.

O medicamento Zofran, cujo princípio ativo é ondansetrona, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade) do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade importante, e o desfecho foi favorável,

com recuperação completa do paciente, embora não haja detalhes sobre a conduta adotada durante o evento.

O medicamento COVID-19 vaccine AstraZeneca, cujo princípio ativo é COVID-19 vaccine NRVV Ad (ChAdOx1 nCoV-19), foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como um distúrbio do sistema imunitário. A reação foi considerada não grave, pois não há indicação de gravidade clínica relevante no registro, e o desfecho foi de recuperação completa. Em casos de alergia leve após vacinação, recomenda-se observação dos sintomas e acompanhamento médico se houver piora, conforme diretrizes clínicas.

O medicamento Arcoxia, que contém o princípio ativo Etoricoxib, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário, mas sem sinais de gravidade clínica relevante e com desfecho desconhecido. Não há informações suficientes para detalhar a conduta adotada ou evolução, mas, diante de suspeita de reação alérgica leve, recomenda-se evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica.

O medicamento Velija, cujo princípio ativo é Duloxetine hydrochloride, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), enquadrado como distúrbio do sistema imunitário, sem evidências de gravidade clínica relevante e com desfecho desconhecido. Não há detalhes sobre a conduta adotada, mas, em situações de alergia leve, é indicado suspender o uso do medicamento suspeito e procurar orientação médica para avaliação e manejo adequados.

O medicamento Lamotrigina, com princípio ativo Lamotrigine, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário, sem sinais de gravidade clínica relevante e com desfecho desconhecido. Não há informações sobre a conduta tomada, mas, em casos de suspeita de alergia leve, recomenda-se interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e definição do tratamento.

O medicamento Bupropion, cujo princípio ativo é Bupropion, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário, sem evidências de gravidade clínica relevante e com desfecho desconhecido. Não há detalhes sobre a conduta adotada, mas, diante de suspeita de alergia leve, é recomendado suspender o uso do medicamento e procurar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas terapêuticas.

O medicamento Cosentyx, cujo princípio ativo é o secukinumabe, foi associado a um quadro de tuberculose descrito como hipersensibilidade, classificado entre quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A ausência de sinais de gravidade sugere que o evento não foi grave, mas é importante monitorar pacientes em uso de Cosentyx para possíveis reações imunológicas, especialmente em casos de sintomas respiratórios ou sinais de infecção.

O medicamento Arcoxia, que contém o princípio ativo etoricoxibe, foi relacionado a um caso de tuberculose manifestando-se como alergia ocular, enquadrada entre infecções e inflamações oculares e distúrbios oculares. Não há evidências de gravidade significativa ou desfecho informado, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Diante da ausência de sinais de gravidade, o evento não foi classificado como grave, mas é recomendável atenção a sintomas oculares em pacientes que utilizam Arcoxia.

O medicamento Velija, cujo princípio ativo é a duloxetina, foi associado a um episódio de tuberculose descrito como alergia ocular, pertencente à categoria de infecções e manifestações oculares e distúrbios oculares. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, e a relação com o medicamento é suspeita. Como não há sinais de gravidade, o evento não foi considerado grave, mas é importante observar possíveis sintomas oculares em pacientes em uso de Velija.

O medicamento Lamotrigina, com princípio ativo lamotrigina, foi relacionado a um caso de tuberculose manifestando-se como alergia ocular, classificada entre infecções e inflamações oculares e distúrbios oculares. Não há indicação de gravidade ou desfecho, e a relação com o medicamento é suspeita. A ausência de sinais de gravidade sugere que o evento não foi grave, mas recomenda-se atenção a sintomas oculares em pacientes que utilizam lamotrigina.

O medicamento Bupropion, cujo princípio ativo é o bupropiona, foi associado a um episódio de tuberculose descrito como alergia ocular, enquadrado entre infecções e manifestações oculares e distúrbios oculares. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, e a relação com o medicamento é suspeita. Como não há sinais de gravidade, o evento não foi considerado grave, mas é importante monitorar sintomas oculares em pacientes em uso de bupropiona.

O medicamento Cosentyx, cujo princípio ativo é o secuquinumabe, foi associado a um quadro de alergia ocular, descrito como infecção, inflamação ou manifestação nos olhos. Embora não haja informação detalhada sobre a gravidade ou desfecho, a relação suspeita com o medicamento sugere a necessidade de acompanhamento clínico para avaliar possíveis complicações oculares, especialmente em pacientes que já apresentam sintomas visuais durante o uso.

O imunizante Comirnaty, que contém o princípio ativo tozinameran, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como clinicamente significativo e considerado grave, já que o evento não foi resolvido até o momento. A suspeita de reação alérgica relevante exige atenção médica imediata e acompanhamento especializado, pois quadros de hipersensibilidade podem evoluir e demandam avaliação criteriosa para evitar riscos maiores ao paciente.

O contraste Omnipaque, cujo princípio ativo é o iohexol, foi associado a uma reação de alergia ao contraste, caracterizada como hipersensibilidade a substâncias químicas. O evento foi considerado uma interação e já está resolvido, indicando que a conduta adotada foi eficaz e não houve complicações persistentes após a exposição ao contraste.

O contraste Ultravist, com princípio ativo iopromida, foi relacionado a um episódio de alergia ao contraste, considerado clinicamente significativo e classificado como grave, com desfecho ainda desconhecido. Diante da suspeita de reação alérgica importante, é fundamental monitorar o paciente e adotar medidas de suporte, pois reações a contrastes podem evoluir rapidamente e requerem intervenção médica imediata.

A fenitoína (princípio ativo fenitoína) foi associada ao surgimento de manchas na pele, caracterizando um quadro de hipersensibilidade. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, mas a suspeita de reação cutânea ao medicamento exige avaliação médica para descartar formas graves de alergia e orientar a conduta adequada, especialmente se houver outros sintomas associados.

O medicamento Oxacilina, cujo princípio ativo é o oxacillin sodium, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente do evento, sugerindo uma reação leve e autolimitada. A conduta recomendada é evitar novas exposições ao medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O Cetoprofeno, com princípio ativo ketoprofen sodium, desencadeou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, classificada entre os distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave, já que houve recuperação completa do paciente, indicando uma manifestação leve. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e consultar um especialista para avaliação e definição de alternativas terapêuticas seguras.

O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é tozinameran, foi utilizado em situação não descrita na bula (off label) e resultou em um quadro de hipersensibilidade, relacionado a distúrbios do sistema imunitário. Não há

informações sobre gravidade ou desfecho, portanto não é possível afirmar a intensidade da reação ou a evolução clínica. Recomenda-se acompanhamento médico para monitoramento e esclarecimento do quadro, especialmente devido ao uso fora das indicações aprovadas.

O contraste Ultravist, com princípio ativo iopromide, foi relacionado a uma alergia a iodo, enquadrada entre as reações alérgicas a medicamentos e outras substâncias químicas, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou totalmente, sugerindo uma reação leve. A orientação é evitar novas exposições a contrastes iodados e buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e planejamento de exames futuros com alternativas seguras.

A Nimesulida, cujo princípio ativo é nimesulide, foi associada à perda do apetite em um contexto de hipersensibilidade, classificada como distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente está em processo de recuperação, indicando uma reação leve. Recomenda-se suspender o uso do medicamento e procurar avaliação médica para acompanhamento da evolução e orientação sobre opções terapêuticas alternativas.

O medicamento Janumet, que contém os princípios ativos metformina e sitagliptina, foi associado a perda do apetite em um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, e o paciente encontra-se em recuperação, sugerindo que a reação foi leve e está evoluindo de forma favorável.

O Esbriet, cujo princípio ativo é a pirfenidona, apresentou como reação adversa a perda do apetite relacionada a um quadro de hipersensibilidade (alergia), também enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade importante e o paciente está em recuperação, indicando que a reação foi leve e está sendo resolvida.

O medicamento Tazocin, composto por piperacilina e tazobactam, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa e o desfecho foi de recuperação completa, sugerindo que a reação foi leve e adequadamente manejada.

O imunizante Comirnaty, cujo princípio ativo é o tozinameran, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade) considerado grave, com ameaça à vida ou outro efeito clinicamente significativo, enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. O paciente ainda não se recuperou, indicando a necessidade de acompanhamento médico rigoroso devido à gravidade do evento.

O Tazocin, contendo piperacilina e tazobactam, esteve envolvido em um episódio de alergia (hipersensibilidade) classificado como distúrbio do sistema imunitário, mas sem sinais de gravidade relevante e com desfecho de recuperação total, indicando que a reação foi leve e resolvida sem complicações.

O medicamento Clenil, cujo princípio ativo é o beclometasona dipropionato, foi associado a um quadro de artrose em um paciente com histórico de alergias múltiplas. Embora a artrose não seja uma reação alérgica típica, o evento foi registrado como suspeito de relação com o uso do medicamento, sem indicação de gravidade clínica relevante ou desfecho conhecido até o momento.

O Aerolin, que contém salbutamol como princípio ativo, foi relacionado a um caso de artrose em paciente com alergias múltiplas. Não há evidências de gravidade significativa ou desfecho informado, e a relação entre o medicamento e a reação foi considerada suspeita, sem informações adicionais sobre evolução clínica.

O medicamento Stezza, composto por estradiol e nomegestrol, foi associado a um episódio de alergia a alimentos em um paciente, sendo a reação considerada suspeita e ainda não resolvida ou em andamento. Não há indicação de gravidade importante, e o caso envolve manifestação alérgica do tipo alimentar, sem detalhes sobre a conduta adotada ou evolução clínica.

O Entresto, que contém sacubitril e valsartana, foi relacionado a um quadro de gripe interpretado como hipersensibilidade, mas sem gravidade clínica relevante e com desfecho favorável, já que o paciente se recuperou completamente. O evento foi considerado suspeito de relação com o medicamento, sem necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é tozinamnerana, foi associado a um episódio de coceira generalizada (prurido), caracterizado como hipersensibilidade e classificado como clinicamente significativo, sugerindo maior gravidade. O desfecho do caso não foi informado, mas a reação foi considerada suspeita de relação com o uso do imunizante.

O medicamento Rosuvastatina, cujo princípio ativo é o rosuvastatina cálcica, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Embora a reação relatada tenha sido um infarto, não há evidências clínicas claras de gravidade ou desfecho informado neste caso, e não foi possível identificar se houve resolução ou necessidade de conduta específica. A ausência de informações detalhadas sobre a gravidade e evolução impede recomendações adicionais, sendo importante acompanhamento médico para avaliação individualizada.

O medicamento Trileptal, que contém o princípio ativo oxcarbazepina, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), caracterizado como um distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa após a reação, não sendo necessário relatar condutas adicionais. Em casos semelhantes, recomenda-se evitar a reexposição ao medicamento e buscar orientação médica para confirmação diagnóstica e manejo futuro.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromida, foi associado a uma reação de alergia a contraste, considerada clinicamente significativa e classificada como grave. O paciente se recuperou totalmente após o evento, indicando resolução do quadro. Em situações de alergia a contraste, é fundamental evitar novas exposições ao agente e informar a equipe médica sobre o histórico, além de considerar alternativas seguras para exames futuros.

O medicamento Vancomicina, com princípio ativo vancomicina hidrocloreídica, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, impossibilitando detalhar a evolução clínica ou conduta adotada. Recomenda-se acompanhamento médico para avaliação de risco em futuras exposições.

O medicamento Rocefin, cujo princípio ativo é ceftriaxona sódica, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há dados sobre gravidade ou desfecho, o que limita a análise da evolução clínica e das medidas tomadas. Em casos de suspeita de alergia, é importante buscar avaliação médica para confirmação e orientação sobre o uso futuro do medicamento.

O medicamento Alemtuzumab, cujo princípio ativo também é Alemtuzumab, foi associado à perda de independência pessoal nas atividades diárias, um quadro de hipersensibilidade (alergia) classificado como distúrbio do sistema imunitário. A gravidade do evento é evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando um impacto clínico significativo. Após a conduta médica adequada, o paciente se recuperou totalmente do episódio.

A vacina CoronaVac, cujo princípio ativo é COVID-19 vaccine inact (Vero) CZ02, foi relacionada ao surgimento de edema ocular, caracterizado como uma reação alérgica nos olhos. Este evento foi considerado clinicamente significativo devido ao potencial impacto ocular, mas não há menção de hospitalização. O paciente encontra-se em processo de recuperação, demonstrando evolução favorável após a manifestação do quadro.

O medicamento Xolair, com princípio ativo Omalizumab, foi associado ao desenvolvimento de hipotireoidismo, interpretado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, dentro dos distúrbios do sistema imunitário.

Não há evidência de gravidade aumentada, como hospitalização, e o paciente evoluiu para recuperação completa após o evento.

O medicamento Budesonid, cujo princípio ativo é Budesonide, esteve relacionado ao surgimento de hipotireoidismo, considerado uma reação de hipersensibilidade medicamentosa e classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade relevante, como necessidade de hospitalização, e o paciente se recuperou totalmente após o episódio.

O medicamento Aerolin, com princípio ativo Salbutamol sulfate, foi associado ao desenvolvimento de hipotireoidismo, interpretado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa dentro dos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, pois não houve necessidade de hospitalização, e o paciente apresentou recuperação completa após a reação.

O medicamento Adrenaline, cujo princípio ativo é Epinephrine, foi associado a um quadro de hipotireoidismo descrito como hipersensibilidade medicamentosa, pertencente à categoria de alergias a medicamentos e distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente após a reação. A conduta adotada não foi detalhada, mas o desfecho favorável sugere resolução espontânea ou após medidas simples.

O medicamento Fluoxetine, com princípio ativo de mesmo nome, esteve relacionado a um episódio de hipotireoidismo classificado como hipersensibilidade medicamentosa, dentro do contexto de alergias a medicamentos e distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa, indicando que a reação foi leve e não exigiu intervenções complexas.

O medicamento Alenia, composto por Budesonide e Formoterol fumarate, foi associado a hipotireoidismo descrito como hipersensibilidade medicamentosa, enquadrando-se em alergias a medicamentos e distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou, sugerindo que a reação foi leve e resolvida sem complicações.

O medicamento Budesonide, com princípio ativo homônimo, esteve envolvido em um caso de hipotireoidismo classificado como hipersensibilidade medicamentosa, relacionado a alergias a medicamentos e distúrbios do sistema imunitário. Não houve gravidade significativa e o paciente se recuperou, indicando um quadro leve e autolimitado.

O medicamento Vancomicina, cujo princípio ativo é Vancomycin, foi relacionado a um episódio de alergia descrito como hipersensibilidade, dentro do contexto de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há informações detalhadas sobre gravidade, conduta ou desfecho, portanto não é possível afirmar a intensidade ou evolução do quadro apenas com os dados fornecidos.

O medicamento Acetilcisteína (princípio ativo: Acetylcysteine) foi associado a um quadro de alergia, descrito como hipersensibilidade, que se enquadra em reações alérgicas do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso está em recuperação ou resolvendo e não foi classificado como grave. A conduta recomendada é observar a evolução dos sintomas, evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas terapêuticas.

A Gadodiamida (princípio ativo: Gadodiamide) foi relacionada a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, caracterizada por manifestações clínicas do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o paciente já se encontra recuperado ou com resolução completa do quadro. Recomenda-se evitar reexposição ao agente e informar o profissional de saúde sobre o episódio para futuras decisões terapêuticas.

O medicamento Prednisone (princípio ativo: Prednisone) foi associado a um caso de hepatite induzida por fármaco, descrita como hipersensibilidade medicamentosa, o que indica uma reação alérgica do sistema imunológico. Não

há evidência de gravidade aumentada, pois não foi classificado como grave e o desfecho é desconhecido. É importante suspender o uso do medicamento sob orientação médica e realizar acompanhamento clínico para monitorar a evolução do quadro.

Methotrexate (princípio ativo: Methotrexate) esteve envolvido em um episódio de hepatite induzida por fármaco, caracterizada como hipersensibilidade medicamentosa, indicando uma reação alérgica do sistema imunológico. O caso não foi considerado grave e o desfecho permanece desconhecido. Recomenda-se interromper o uso do medicamento sob supervisão médica e realizar avaliação clínica para acompanhamento e definição de conduta.

Chloroquine (princípio ativo: Chloroquine) foi associada a um quadro de hepatite induzida por fármaco, descrito como hipersensibilidade medicamentosa, o que sugere uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade aumentada, pois não foi classificado como grave e o desfecho é desconhecido. A orientação é suspender o uso do medicamento sob orientação médica e realizar acompanhamento clínico para monitorar possíveis complicações.

O medicamento Mabthera, cujo princípio ativo é o rituximabe, foi associado a um caso de hepatite induzida por fármaco, caracterizando uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. Embora não haja indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, trata-se de uma manifestação imunológica adversa que requer atenção clínica para monitoramento e possível ajuste terapêutico, conforme orientações da ASBAI para reações alérgicas a medicamentos.

O Actemra, com princípio ativo tocilizumabe, esteve relacionado a um episódio de hepatite induzida por fármaco, configurando uma hipersensibilidade medicamentosa. Não há registro de gravidade importante ou desfecho definido, mas a reação sugere envolvimento do sistema imunológico e demanda acompanhamento médico para avaliação da necessidade de suspensão ou substituição do tratamento, conforme recomendações para alergias medicamentosas.

O imunizante Comirnaty, cujo princípio ativo é tozinameran, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como clinicamente significativo e grave, mas com evolução para recuperação completa. A reação envolveu o sistema imunológico e, diante da gravidade relatada, a conduta recomendada é a avaliação médica imediata e acompanhamento especializado, seguindo as diretrizes para eventos alérgicos graves.

A ceftriaxona, com princípio ativo ceftriaxone sodium, foi relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), envolvendo o sistema imunológico, sem indicação de gravidade elevada e com desfecho favorável, já que o paciente se recuperou. Nesses casos, é importante a identificação do agente causador e o acompanhamento médico para evitar novas exposições e garantir segurança em futuras prescrições.

A Polimixina B, cujo princípio ativo é polymyxin b, esteve envolvida em um caso de alergia (hipersensibilidade), sem gravidade significativa e com recuperação completa do paciente. A reação foi imunológica e, conforme as orientações clínicas, recomenda-se evitar reexposição ao medicamento e manter acompanhamento para prevenção de novos episódios alérgicos.

O medicamento Erbitux, cujo princípio ativo é o cetuximabe, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade aumentada neste caso, e o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo que a reação foi leve e controlada, sem necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Comirnaty, que contém o princípio ativo tozinamerana, esteve relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), também envolvendo o sistema imunológico. Neste caso, a reação foi considerada clinicamente significativa e grave, pois permanece não resolvida ou em andamento, indicando a necessidade de acompanhamento médico contínuo para monitoramento e manejo adequado da condição.

O medicamento Optiray 320, cujo princípio ativo é o ioversol, foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), envolvendo o sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade aumentada, e o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo que a reação foi leve e não deixou sequelas.

O medicamento Novalgina, com princípio ativo metamizol sódico, foi relacionado a um quadro de agitação associado a hipersensibilidade documentada ao produto administrado. Não há detalhes sobre a gravidade ou evolução do caso, portanto não é possível afirmar a intensidade da reação ou o desfecho clínico apenas com os dados fornecidos.

O medicamento Ceftriaxona, cujo princípio ativo é a ceftriaxona, esteve envolvido em um episódio de alergia (hipersensibilidade), afetando o sistema imunológico. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando que a reação foi leve e adequadamente resolvida.

O medicamento Cimzia (Certolizumab pegol) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, caracterizado como uma reação alérgica relevante do sistema imunológico. A gravidade foi considerada clinicamente significativa, pois o evento foi classificado como grave e ainda está em andamento, sem resolução até o momento. Diante desse cenário, é fundamental acompanhamento médico rigoroso para monitorar a evolução do quadro e avaliar a necessidade de intervenções específicas, conforme orientações da ASBAI para reações alérgicas graves a medicamentos.

A Prednisolona (Prednisolone) foi relacionada a um episódio de alergia a poeira, que se manifestou como uma reação alérgica do sistema imunológico. O evento foi considerado grave, com risco potencial à vida e possibilidade de anomalias congênitas, mas o paciente evoluiu para recuperação completa. Nesses casos, é essencial evitar a exposição ao alérgeno e manter acompanhamento médico para prevenir recorrências, seguindo as recomendações de manejo de alergias respiratórias da ASBAI.

O uso de Amoxicina (Amoxicillin trihydrate) resultou em uma reação de alergia a poeira, caracterizada como um distúrbio do sistema imunológico. A gravidade foi classificada como ameaça à vida e risco de anomalias congênitas, porém o paciente se recuperou totalmente. É importante que, diante de reações alérgicas graves, o paciente seja avaliado por um especialista para confirmação diagnóstica e definição de estratégias de prevenção, conforme orientações clínicas para alergias medicamentosas.

O medicamento Naglazyme (Galsulfase) foi associado a uma reação de alergia a poeira, considerada um distúrbio imunológico de alta gravidade, com risco de ameaça à vida e possibilidade de anomalias congênitas. Apesar da gravidade, o paciente apresentou resolução completa do quadro. Em situações como essa, recomenda-se acompanhamento especializado para monitoramento e prevenção de novas reações, conforme as diretrizes da ASBAI para alergias graves.

O medicamento Reconter (Escitalopram oxalate) foi relacionado a um quadro de diarreia, interpretado como possível manifestação de alergia ao leite, envolvendo o sistema imunológico. O evento não foi considerado grave, mas permanece sem resolução até o momento. É importante que o paciente seja acompanhado para avaliação da persistência dos sintomas e investigação de possíveis causas alimentares ou medicamentosas, conforme recomendações para alergias alimentares.

O medicamento Reconter, cujo princípio ativo é o escitalopram oxalato, foi associado ao surgimento de diarreia em um paciente, sendo classificado como uma possível reação alérgica a alimentos ou substâncias químicas. Não há indicação de gravidade elevada, pois não foram relatados sintomas sistêmicos graves ou risco imediato, e o quadro permanece em andamento, sem resolução até o momento. Recomenda-se acompanhamento clínico para monitorar a evolução dos sintomas e avaliar a necessidade de ajuste terapêutico, conforme orientação médica.

O imunizante Comirnaty, que contém o princípio ativo tozinameran, foi relacionado ao aparecimento de coceira generalizada, caracterizando um quadro de hipersensibilidade (alergia). Não há sinais de gravidade importante,



como envolvimento respiratório ou cardiovascular, e o desfecho permanece desconhecido. É importante observar a evolução dos sintomas e buscar avaliação médica caso haja piora ou surgimento de outros sinais de alergia.

O produto Collagen, com princípio ativo de mesmo nome, foi associado ao desenvolvimento de bronquite, sugerindo uma possível reação alérgica a substâncias químicas. Não há informações sobre gravidade significativa ou complicações, e o desfecho do caso não foi informado. Recomenda-se investigação clínica para confirmar a relação causal e orientar o manejo adequado, especialmente se houver recorrência dos sintomas.

O medicamento Hydroxychloroquine, cujo princípio ativo é a hidroxicloroquina, foi relacionado ao surgimento de bronquite, indicando uma possível reação alérgica a substâncias químicas. Não há evidências de gravidade elevada ou complicações sistêmicas, e o desfecho permanece desconhecido. É recomendável acompanhamento médico para avaliar a necessidade de suspensão do medicamento e monitorar a evolução clínica.

O medicamento Predsim, que contém prednisolona fosfato sódico como princípio ativo, foi associado ao aparecimento de bronquite, sugerindo uma possível reação alérgica a substâncias químicas. Não há sinais de gravidade importante relatados e o desfecho do caso não foi informado. Recomenda-se avaliação médica para investigar a relação causal e definir a conduta mais adequada, considerando a persistência dos sintomas.

O medicamento Actemra (princípio ativo: Tocilizumab) foi associado ao desenvolvimento de bronquite, um quadro de inflamação dos brônquios que pode estar relacionado a reações alérgicas a medicamentos. Embora a gravidade não tenha sido explicitamente informada, não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave, e o desfecho permanece desconhecido. A relação suspeita com o medicamento sugere a necessidade de acompanhamento clínico para avaliar a evolução e considerar medidas de controle ambiental e identificação de possíveis gatilhos, conforme orientações para alergias respiratórias.

No caso da Amoxicilina (princípio ativo: Amoxicillin), ocorreu um erro de administração em que o produto foi dado ao paciente incorreto, resultando em exposição a um medicamento ao qual havia hipersensibilidade documentada. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou evolução clínica, mas a situação exige atenção imediata para evitar reações adversas, especialmente em pacientes com histórico de alergia, e reforça a importância de protocolos de segurança para prevenir erros de medicação.

O medicamento Copaxone (princípio ativo: Glatiramer acetate) foi relacionado ao surgimento de encefalite não infecciosa, um quadro de inflamação cerebral que, neste contexto, está associado a uma reação de hipersensibilidade (alergia). Não há indicação de gravidade elevada e o caso está em recuperação, sugerindo que a reação foi reconhecida e está sendo manejada adequadamente, com acompanhamento clínico para monitorar a resolução dos sintomas.

Copaxone (princípio ativo: Glatiramer acetate) também foi associado a encefalite não infecciosa por hipersensibilidade, com evolução semelhante ao caso anterior, sem gravidade elevada e com o paciente em recuperação. O acompanhamento clínico é fundamental para garantir a resolução completa do quadro e prevenir complicações.

O medicamento Comirnaty (princípio ativo: Tozinameran) foi relacionado a um episódio de febre reumática, considerada aqui como uma manifestação de hipersensibilidade medicamentosa. Não há indicação de gravidade elevada nem detalhes sobre o desfecho, mas a suspeita de relação com o medicamento exige avaliação médica para monitorar possíveis complicações e orientar a conduta adequada, conforme recomendações para reações alérgicas a medicamentos.

O medicamento Losartana potássica (princípio ativo: Losartan potassium) foi associado a um quadro de febre reumática, interpretado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta exagerada do sistema imunológico ao medicamento. Não há indicação de gravidade elevada, pois não foram relatados sinais de gravidade clínica nem desfecho grave, e o desfecho permanece desconhecido. A relação entre o uso do

medicamento e a reação é considerada suspeita, sendo importante monitorar sintomas e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e conduta adequada.

O suplemento Omega 3 (princípio ativo: óleo de peixe) foi relacionado a um episódio de febre reumática, classificado como hipersensibilidade medicamentosa, o que significa uma possível reação alérgica ao produto. Não há informações sobre gravidade significativa ou desfecho grave, e o resultado da reação é desconhecido. A relação entre o uso do suplemento e a reação é considerada suspeita, sendo recomendada a observação dos sintomas e consulta médica para esclarecimento.

O medicamento Hidroclorotiazida (princípio ativo: Hydrochlorothiazide) foi associado a um quadro de febre reumática, interpretado como hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma possível reação alérgica ao medicamento. Não há evidências de gravidade importante ou desfecho grave, e o desfecho permanece desconhecido. A relação entre o uso do medicamento e a reação é considerada suspeita, sendo indicado acompanhamento clínico para avaliação e definição da conduta.

O medicamento Sulfato de salbutamol (princípio ativo: Salbutamol sulfate) foi relacionado a um episódio de febre reumática, classificado como hipersensibilidade medicamentosa, indicando uma possível reação alérgica ao medicamento. Não há sinais de gravidade relevante ou desfecho grave, e o desfecho é desconhecido. A relação entre o uso do medicamento e a reação é considerada suspeita, sendo importante monitorar sintomas e buscar orientação médica para confirmação e manejo adequado.

O imunizante Comirnaty (princípio ativo: Tozinameran) foi associado a dor articular, interpretada como uma manifestação de hipersensibilidade, ou seja, uma reação do sistema imunológico ao medicamento. Não há evidências de gravidade importante, pois não foi relatado desfecho grave, mas o quadro permanece não resolvido ou em andamento. A relação entre o uso do imunizante e a reação é considerada suspeita, sendo recomendada avaliação médica para acompanhamento dos sintomas e definição da conduta.

O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é o Tozinameran, foi associado a uma reação cutânea descrita como alergia a alimentos, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade relevante ou desfecho conhecido, e não foram relatados detalhes sobre a conduta adotada. A reação parece ter sido leve, sem evidências de complicações graves, e o caso permanece sem informações conclusivas sobre a evolução clínica.

O imunizante CoronaVac, com princípio ativo COVID-19 vaccine inact (Vero) CZ02, esteve relacionado a um quadro de alergia classificado como hipersensibilidade, considerado clinicamente significativo e grave, mas com desfecho favorável, já que o paciente se recuperou. A reação foi enquadrada como distúrbio do sistema imunitário, e a gravidade foi sustentada pela classificação de outro efeito clinicamente significativo, indicando a necessidade de atenção médica e acompanhamento até a resolução.

O medicamento Naratriptan, cujo princípio ativo é o próprio Naratriptan, foi relacionado a uma reação de ressecção ileal, descrita como hipersensibilidade e classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade relevante, e o paciente encontra-se em recuperação, sugerindo que a reação foi moderada e está sendo acompanhada clinicamente, sem informações adicionais sobre a conduta adotada.

O medicamento Miosan, com princípio ativo cloridrato de ciclobenzaprina, foi associado a uma reação de ressecção ileal, caracterizada como hipersensibilidade e enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa, e o paciente está em processo de recuperação, indicando que a reação foi moderada e está sob acompanhamento, sem detalhes adicionais sobre intervenções específicas.

O medicamento Tramal, cujo princípio ativo é o cloridrato de tramadol, foi relacionado a uma reação de ressecção ileal, descrita como hipersensibilidade e classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade importante, e o paciente está em recuperação, sugerindo que a reação foi moderada e está sendo

monitorada clinicamente, sem informações adicionais sobre a conduta adotada.

O medicamento Patanol, cujo princípio ativo é o olopatadina, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), manifestado clinicamente como ressecção ileal, o que sugere uma reação alérgica sistêmica envolvendo o sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente encontra-se em recuperação ou resolvendo, e não há relato de desfecho grave. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico para monitorar a evolução e evitar nova exposição ao medicamento.

A azatioprina, cujo princípio ativo é o próprio azathioprine, foi relacionada a um episódio de hipersensibilidade (alergia), também descrito como ressecção ileal, indicando envolvimento do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave, pois o paciente está em recuperação ou resolvendo, e não há relato de complicações maiores. Recomenda-se acompanhamento médico e suspensão do uso do medicamento, conforme evolução clínica.

O medicamento Humira, com princípio ativo adalimumabe, apresentou associação com hipersensibilidade (alergia), manifestada como ressecção ileal, caracterizando uma reação alérgica sistêmica. Não há evidência de gravidade significativa, já que o paciente está em recuperação ou resolvendo, e não há relato de desfecho grave. A orientação é manter acompanhamento clínico e evitar nova exposição ao agente suspeito.

A clindamicina, cujo princípio ativo é clindamycin, foi relacionada a um quadro de hipersensibilidade (alergia), sem detalhamento adicional sobre sintomas ou evolução. Não há indicação de gravidade ou desfecho informado, mas, diante de suspeita de reação alérgica, recomenda-se avaliação médica para confirmação e definição de conduta, incluindo possível suspensão do medicamento.

O ácido acetilsalicílico (Acetylsalicylic acid), tanto nome comercial quanto princípio ativo, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), descrito como alergia sem outra especificação, envolvendo o sistema imunitário. Não há relato de gravidade ou desfecho conhecido, mas, diante da suspeita de reação alérgica, é importante evitar nova exposição e buscar avaliação médica para orientação adequada.

O medicamento Amlodipine, cujo princípio ativo também é Amlodipine, foi associado a um quadro de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica inespecífica (SOE) envolvendo o sistema imunológico. Não há detalhes sobre sintomas específicos, gravidade clínica ou desfecho do caso, mas a ausência de indicação de gravidade sugere que não houve sinais de gravidade importante. Recomenda-se atenção a sintomas alérgicos e, caso persistam ou piorem, buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação adequada.

O medicamento Atenolol, com princípio ativo Atenolol, apresentou relato de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica inespecífica (SOE) relacionada ao sistema imunológico. Não foram fornecidos detalhes sobre sintomas, gravidade ou evolução, e não há indicação de gravidade relevante. Em situações como essa, é importante observar possíveis manifestações alérgicas e procurar avaliação médica caso haja persistência ou agravamento dos sintomas.

O medicamento Maxiflor, cujo princípio ativo é Diflorasone diacetate, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica inespecífica (SOE) envolvendo o sistema imunológico. Não há informações sobre sintomas específicos, gravidade clínica ou desfecho, e não foi relatada gravidade importante. Recomenda-se monitorar sinais de alergia e buscar orientação médica se houver piora ou persistência do quadro.

O medicamento Ecofilm, com princípio ativo Carmellose sodium, foi associado a um caso de hipersensibilidade, indicando uma reação alérgica inespecífica (SOE) do sistema imunológico. Não há detalhes sobre sintomas, gravidade ou evolução do caso, e não foi identificada gravidade relevante. É importante observar possíveis sinais de alergia e procurar avaliação médica se houver agravamento ou manutenção dos sintomas.

O medicamento Losartan, cujo princípio ativo também é Losartan, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica inespecífica (SOE) do sistema imunológico. Não foram

descritos sintomas específicos, gravidade clínica ou desfecho, e não há indicação de gravidade importante. Recomenda-se atenção a manifestações alérgicas e, caso haja persistência ou piora, buscar avaliação médica para diagnóstico e conduta adequada.

O medicamento Metformin, cujo princípio ativo também é Metformin, foi associado a um quadro de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do tipo SOE (sem outra especificação), classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade aumentada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Em casos de alergia leve, recomenda-se observar sintomas, evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas terapêuticas.

O Actemra, cujo princípio ativo é Tocilizumab, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, caracterizado como alergia SOE, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há registro de gravidade aumentada ou desfecho informado, e a relação com o medicamento é suspeita. Diante de suspeita de reação alérgica leve, é importante suspender o uso do medicamento e procurar avaliação médica para confirmação e definição do melhor manejo.

O medicamento Comirnaty, com princípio ativo Tozinameran, foi associado a uma reação de hipersensibilidade (alergia) considerada grave, pois houve ameaça à vida e o desfecho foi recuperação com sequelas. Reações alérgicas graves exigem suspensão imediata do medicamento, atendimento de emergência e acompanhamento especializado para manejo das possíveis sequelas e prevenção de novas exposições.

O Ibuprofeno, cujo princípio ativo é Ibuprofen, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade manifestado como pneumonia, classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade aumentada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é suspeita. Em situações como essa, recomenda-se suspender o uso do medicamento e buscar avaliação médica para investigação da relação causal e definição do tratamento adequado.

A Acetilcisteína, com princípio ativo Acetylcysteine, foi associada a um episódio de hipersensibilidade manifestado como pneumonia, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há registro de gravidade aumentada ou desfecho informado, e a relação com o medicamento é suspeita. Diante desse quadro, é indicado interromper o uso do medicamento e procurar avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e conduta apropriada.

O medicamento Loratadina (princípio ativo: Loratadine) foi associado a um quadro de pneumonia, interpretado como uma possível reação de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico. Embora a gravidade não tenha sido especificada e o desfecho seja desconhecido, não há indicação de gravidade elevada neste caso, sugerindo que a reação não foi considerada grave segundo o registro clínico. A relação entre o uso do medicamento e o evento é suspeita, e recomenda-se acompanhamento médico para avaliação e confirmação diagnóstica.

A Hidroxicloroquina (princípio ativo: Hydroxychloroquine) foi relacionada a um episódio de pneumonia, classificado como possível manifestação de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade aumentada ou desfecho, e o evento não foi considerado grave conforme o registro, sendo a relação com o medicamento suspeita. É importante que o paciente seja avaliado por um profissional de saúde para investigação adequada.

O medicamento Decortin (princípio ativo: Prednisone) foi associado a um caso de pneumonia, interpretado como uma possível reação de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade aumentada nem detalhes sobre o desfecho, e o evento não foi considerado grave segundo o registro clínico. A relação com o medicamento é suspeita, sendo recomendada avaliação médica para esclarecimento.

O medicamento Labirin (princípio ativo: Betahistine hydrochloride) foi relacionado a um episódio de pneumonia, considerado uma possível reação de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade aumentada ou desfecho, e o evento não foi classificado como grave, sendo a relação com o medicamento suspeita. Recomenda-se acompanhamento médico para investigação do quadro.

O medicamento Reuquinol (princípio ativo: Hydroxychloroquine sulfate) foi associado a um caso de pneumonia, interpretado como possível reação de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade aumentada nem detalhes sobre o desfecho, e o evento não foi considerado grave conforme o registro clínico. A relação com o medicamento é suspeita, sendo importante avaliação médica para confirmação diagnóstica.

O medicamento Dipirona (princípio ativo: Metamizole sodium) foi associado a um quadro de pneumonia, sendo classificado como uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta exagerada do sistema imunológico. Não há informações sobre a gravidade clínica específica ou sobre o desfecho do caso, mas a relação suspeita entre o uso do medicamento e o evento sugere a necessidade de atenção médica para investigação e manejo adequado, conforme orientações para quadros alérgicos respiratórios.

Azatioprina (princípio ativo: Azathioprine) foi relacionada ao desenvolvimento de pneumonia, caracterizada como uma reação de hipersensibilidade, indicando possível envolvimento do sistema imunológico. Não há detalhes sobre a gravidade ou evolução do caso, mas a suspeita de relação entre o medicamento e o evento reforça a importância de avaliação médica para confirmação diagnóstica e conduta apropriada, especialmente em pacientes imunossuprimidos.

O medicamento Trok, que contém Betamethasone dipropionate e Ketoconazole, foi associado a um episódio de pneumonia, descrito como reação de hipersensibilidade, sugerindo uma resposta imunológica inadequada. Não há informações sobre a gravidade ou o desfecho do caso, mas a suspeita de relação entre o uso do medicamento e o evento indica a necessidade de acompanhamento clínico para investigação e manejo, conforme recomendações para quadros alérgicos respiratórios.

Prednisona (princípio ativo: Prednisone) foi relacionada a um caso de pneumonia, classificada como reação de hipersensibilidade, o que sugere envolvimento do sistema imunológico. Não há dados sobre a gravidade ou evolução do quadro, mas a suspeita de associação entre o medicamento e o evento reforça a importância de avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e definição da conduta, especialmente em pacientes em uso prolongado de corticoides.

Clavulin (princípios ativos: Amoxicillin sodium e Clavulanate potassium) foi associado a um episódio de pneumonia, descrito como reação de hipersensibilidade, indicando possível resposta imunológica inadequada ao medicamento. Não há informações sobre a gravidade ou o desfecho do caso, mas a suspeita de relação entre o uso do medicamento e o evento sugere a necessidade de avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação terapêutica adequada.

O medicamento Benlysta, cujo princípio ativo é o belimumabe, foi associado a um quadro de pneumonia em um contexto de hipersensibilidade, sugerindo uma reação alérgica do tipo imunológica. Embora a gravidade não tenha sido explicitamente informada, a suspeita de envolvimento do sistema imune e a natureza da reação indicam a necessidade de acompanhamento clínico cuidadoso, especialmente porque o desfecho permanece desconhecido.

O medicamento Ultravist, com princípio ativo iopromida, foi relacionado a um episódio de alergia a contraste, caracterizado como um efeito clinicamente significativo e considerado grave devido ao potencial risco de reações alérgicas sistêmicas associadas a contrastes iodados. O desfecho do caso não foi informado, sendo fundamental a avaliação médica imediata e medidas de suporte em situações semelhantes.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é iopromida, esteve envolvido em uma reação de alergia a contraste, classificada como clinicamente significativa e grave, o que reforça a importância de monitoramento rigoroso durante e após a administração de contrastes, já que reações alérgicas podem evoluir rapidamente e o desfecho neste caso não foi especificado.

O medicamento Ultravist, com princípio ativo iopromida, foi novamente associado a uma reação de alergia a contraste considerada grave e clinicamente relevante, destacando o risco de reações alérgicas importantes com o uso de contrastes iodados e a necessidade de pronta intervenção médica, especialmente porque o desfecho permanece desconhecido.

O medicamento Myrafer, cujo princípio ativo é fumarato ferroso, foi relacionado a um episódio de coceira (prurido) por hipersensibilidade, classificado como clinicamente significativo e grave, mas com evolução favorável, já que o paciente se recuperou totalmente após a reação, evidenciando a importância de suspender o medicamento e monitorar sintomas alérgicos.

O medicamento Vitamin D, cujo princípio ativo é o colecalciferol, foi associado a um quadro de coceira, caracterizando uma reação de hipersensibilidade (alergia) do tipo clínico alérgico, relacionada ao sistema imunológico. A gravidade foi considerada clinicamente significativa, pois a reação foi classificada como grave, mas o paciente evoluiu para recuperação completa após a conduta adequada. Tanto o nome comercial quanto o princípio ativo estão disponíveis para referência.

A Vitamina C, com princípio ativo ácido ascórbico, desencadeou um episódio de coceira, indicando uma reação de hipersensibilidade (alergia) de natureza imunológica. O evento foi considerado clinicamente relevante e grave, mas o paciente se recuperou totalmente após a suspensão ou manejo do medicamento. Tanto o nome comercial quanto o princípio ativo estão informados.

O medicamento Neosine, cujo princípio ativo é inosina pranobex, provocou coceira, caracterizando uma reação alérgica (hipersensibilidade) mediada pelo sistema imunológico. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, mas o paciente apresentou resolução completa do quadro após a conduta apropriada. Tanto o nome comercial quanto o princípio ativo estão presentes.

O medicamento Glifage XR, com princípio ativo cloridrato de metformina, foi relacionado ao surgimento de coceira, indicando uma reação de hipersensibilidade (alergia) do tipo imunológica. O evento foi classificado como clinicamente relevante e grave, porém o paciente se recuperou totalmente após a intervenção adequada. Tanto o nome comercial quanto o princípio ativo estão disponíveis.

O medicamento Topiramato, cujo princípio ativo é topiramato, desencadeou um quadro de coceira, caracterizando uma reação alérgica (hipersensibilidade) mediada pelo sistema imunológico. A gravidade foi considerada clinicamente significativa e grave, mas houve recuperação completa do paciente após a conduta apropriada. Tanto o nome comercial quanto o princípio ativo estão informados.

O medicamento Sertralina (princípio ativo: Sertraline) foi associado ao surgimento de coceira, caracterizando um quadro de hipersensibilidade (alergia), que faz parte dos distúrbios do sistema imunitário. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, pois exigiu atenção médica, mas o paciente se recuperou totalmente após a conduta adequada. A relação entre o uso do medicamento e o evento foi considerada suspeita.

O Pantoprazol (princípio ativo: Pantoprazole sodium sesquihydrate) desencadeou um episódio de coceira, indicando uma reação de hipersensibilidade (alergia) relacionada ao sistema imunológico. O evento foi classificado como clinicamente significativo e grave, justificando acompanhamento médico, porém o paciente evoluiu para recuperação completa. O vínculo entre o uso do medicamento e a reação foi considerado suspeito.

O Puran t4 (princípio ativo: Levothyroxine sodium) esteve associado ao aparecimento de coceira, sugerindo uma reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico. O caso foi considerado clinicamente relevante e grave, o que indica necessidade de avaliação médica, mas o paciente se recuperou após a conduta apropriada. A relação entre o medicamento e o evento foi considerada suspeita.

O imunizante Comirnaty (princípio ativo: Tozinameran) foi relacionado ao surgimento de coceira, caracterizando uma reação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imune. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, exigindo atenção médica, mas o paciente se recuperou totalmente após as medidas adotadas. A relação entre o uso do imunizante e a reação foi considerada suspeita.

O Rotateq (princípio ativo: Rotavirus vaccine live reassort oral 5v) foi associado ao aparecimento de hematoquezia (presença de sangue nas fezes), em um contexto de possível alergia alimentar, sem gravidade clínica evidente até o momento. O paciente ainda não se recuperou totalmente, estando o quadro em andamento, e a relação entre o uso do imunizante e o evento foi considerada suspeita.

O medicamento Vancomicina (princípio ativo: Vancomycin hydrochloride) foi associado a um quadro de alergia, descrito como hipersensibilidade, envolvendo manifestações clínicas alérgicas do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações, e o desfecho informado foi de recuperação completa, sugerindo um evento leve e autolimitado. A conduta recomendada é evitar novas exposições ao medicamento e buscar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e orientação futura.

O medicamento Plasil (princípio ativo: Metoclopramide hydrochloride) foi relacionado a uma reação alérgica, caracterizada como hipersensibilidade medicamentosa, envolvendo o sistema imunológico. Não há relato de gravidade importante ou complicações, e o desfecho permanece desconhecido. Diante de suspeita de alergia medicamentosa, recomenda-se suspender o uso do medicamento e procurar avaliação médica para investigação e orientação adequada.

A Dipirona (princípio ativo: Metamizole sodium) foi associada a uma reação alérgica, descrita como hipersensibilidade medicamentosa, afetando o sistema imunológico. Não há sinais de gravidade ou complicações relatadas, e o desfecho é desconhecido. Em casos de suspeita de alergia à dipirona, é importante interromper o uso e buscar avaliação médica para confirmação e definição de alternativas seguras.

O medicamento Sulfadiazina (princípio ativo: Sulfadiazine) foi relacionado a uma reação alérgica, classificada como hipersensibilidade medicamentosa, envolvendo o sistema imunológico. Não há evidências de gravidade ou complicações, e o desfecho não foi informado. Recomenda-se suspender o uso do medicamento e procurar avaliação médica para investigação e orientação sobre alternativas terapêuticas.

O medicamento Zinnat (princípio ativo: Cefuroxime axetil) foi associado a uma reação alérgica, descrita como hipersensibilidade medicamentosa, com envolvimento do sistema imunológico. Não há relato de gravidade ou complicações, e o desfecho é desconhecido. Diante de suspeita de alergia, recomenda-se interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição de conduta.

O medicamento Diphenhydramine, cujo princípio ativo também é Diphenhydramine, foi associado a um quadro de hipersensibilidade caracterizado por deficiência de imunidade não especificada, o que sugere uma reação alérgica relevante do tipo distúrbio do sistema imunitário. A gravidade do caso é evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando que a reação foi considerada grave. O paciente encontra-se em recuperação ou com resolução dos sintomas, e a relação do evento com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Ondansetron, com princípio ativo Ondansetron, esteve relacionado a uma reação de hipersensibilidade manifestada como deficiência de imunidade não especificada, enquadrando-se em distúrbios do sistema imunitário. O caso foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da

internação, o que reforça a importância do acompanhamento médico. O paciente está em processo de recuperação ou resolução do quadro, e a relação do evento adverso com o uso do medicamento é suspeita.

O medicamento Methylprednisolone, cujo princípio ativo é Methylprednisolone, foi associado a uma reação de hipersensibilidade descrita como deficiência de imunidade não especificada, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. A gravidade do evento é confirmada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando um quadro clínico importante. O paciente está em recuperação ou com resolução dos sintomas, e a relação do evento com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Doxazosin, com princípio ativo Doxazosin, foi relacionado a uma reação de hipersensibilidade caracterizada por deficiência de imunidade não especificada, classificada como distúrbio do sistema imunitário. O caso foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que demonstra a importância do monitoramento clínico. O paciente encontra-se em recuperação ou com resolução do quadro, e a relação do evento adverso com o medicamento é suspeita.

O medicamento Oxybutynine, cujo princípio ativo é Oxybutynin hydrochloride, esteve associado a uma reação de hipersensibilidade manifestada como deficiência de imunidade não especificada, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. A gravidade do evento é evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando um quadro clínico relevante. O paciente está em recuperação ou com resolução dos sintomas, e a relação do evento com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Sertraline (princípio ativo: Sertraline) foi associado a um quadro de deficiência de imunidade não especificada, interpretado como uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta exagerada do sistema imunológico ao medicamento. Este evento foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, indicando a necessidade de acompanhamento médico rigoroso e possível intervenção hospitalar. O paciente encontra-se em recuperação ou com resolução do quadro, sugerindo que as medidas adotadas foram eficazes até o momento.

O medicamento Alemtuzumab (princípio ativo: Alemtuzumab) apresentou como reação adversa uma deficiência de imunidade não especificada, caracterizada como hipersensibilidade, ou seja, uma resposta anormal do sistema imunológico ao fármaco. A gravidade do caso é evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que reforça a importância de monitoramento médico intensivo. O paciente está em processo de recuperação ou resolução do quadro, indicando resposta positiva às medidas adotadas.

O medicamento CoronaVac, cujo princípio ativo é a vacina COVID-19 inativada (Vero) CZ02, foi relacionado a um caso de catarata bilateral, descrito como hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma possível reação alérgica ao imunizante. Não há indicação de gravidade aumentada ou necessidade de hospitalização, e o desfecho do caso permanece desconhecido, não sendo possível afirmar a evolução clínica ou a conduta adotada.

O medicamento Loratadine (princípio ativo: Loratadine) foi associado a um caso de catarata bilateral, classificado como hipersensibilidade medicamentosa, o que sugere uma possível reação alérgica ao medicamento. Não há evidências de gravidade aumentada ou necessidade de hospitalização, e o desfecho do caso é desconhecido, não sendo possível detalhar a evolução clínica ou as medidas tomadas.

O medicamento Ivermectin (princípio ativo: Ivermectin) foi relacionado a um caso de catarata bilateral, descrito como hipersensibilidade medicamentosa, indicando uma possível reação alérgica ao uso do medicamento. Não há informações que apontem para gravidade aumentada ou necessidade de hospitalização, e o desfecho do caso permanece desconhecido, sem detalhes sobre a evolução clínica ou conduta adotada.

O medicamento Bleomycin, cujo princípio ativo é também Bleomycin, foi associado ao desenvolvimento de catarata bilateral, um efeito adverso raro relacionado à hipersensibilidade medicamentosa. Embora não haja indicação de gravidade elevada ou necessidade de hospitalização, é importante monitorar sintomas oculares e considerar



avaliação oftalmológica, pois a relação com o medicamento é considerada suspeita e o desfecho permanece desconhecido.

O Puran t4, que contém o princípio ativo Levothyroxine sodium, foi relacionado ao surgimento de catarata bilateral, um evento adverso incomum que pode estar ligado a uma reação de hipersensibilidade ao medicamento. Não há evidências de gravidade significativa ou de hospitalização, mas recomenda-se atenção a alterações visuais e acompanhamento médico, já que a relação com o uso do medicamento é suspeita e o desfecho não foi informado.

O medicamento Sertraline, cujo princípio ativo é Sertraline hydrochloride, foi associado à ocorrência de catarata bilateral, possivelmente como manifestação de hipersensibilidade medicamentosa. Não há sinais de gravidade importante ou necessidade de internação, mas é prudente observar sintomas visuais e buscar avaliação médica, pois a relação com o medicamento é considerada suspeita e o desfecho não foi especificado.

O Flixotide, que tem como princípio ativo o Fluticasone propionate, foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), com gravidade suficiente para exigir hospitalização ou prolongamento da internação. Isso indica uma reação alérgica significativa, sendo fundamental a suspensão do medicamento e acompanhamento médico rigoroso, já que o desfecho do caso não foi informado e a relação com o uso do medicamento é suspeita.

A Hidroxicloroquina, cujo princípio ativo é Hydroxychloroquine sulfate, foi associada ao desenvolvimento de lúpus eritematoso sistêmico, uma reação de hipersensibilidade que pode envolver múltiplos órgãos. Apesar de não haver indicação de gravidade elevada ou necessidade de hospitalização, é importante monitorar sintomas e realizar acompanhamento médico, pois a relação com o medicamento é suspeita e o desfecho permanece desconhecido.

O medicamento Cloroquina (princípio ativo: Chloroquine) foi associado a um quadro de hipersensibilidade manifestado como lúpus eritematoso sistêmico, uma reação do sistema imunológico que pode envolver sintomas variados e requer atenção médica. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido neste caso, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo importante monitorar o paciente e avaliar a necessidade de acompanhamento especializado.

O medicamento Benlysta (princípio ativo: Belimumab) foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, descrito como lúpus eritematoso sistêmico, indicando uma resposta imunológica alterada. Não há informações sobre gravidade significativa ou desfecho, e a relação com o medicamento é suspeita, recomendando-se observação clínica e investigação adicional caso surjam sintomas persistentes.

O medicamento Paclitaxel (princípio ativo: Paclitaxel) provocou uma reação alérgica classificada como hipersensibilidade, considerada clinicamente significativa e grave, mas o paciente se recuperou totalmente após o evento. A relação com o medicamento é suspeita, sendo fundamental que, diante de sintomas alérgicos graves, o paciente seja avaliado imediatamente por equipe médica para manejo adequado e prevenção de novas exposições.

O medicamento Letrozole (princípio ativo: Letrozole) foi associado a um quadro de hipersensibilidade manifestado como imunodeficiência, ou seja, uma alteração na resposta do sistema imunológico, mas sem gravidade relevante e com recuperação completa do paciente. A relação com o medicamento é suspeita, sendo importante manter acompanhamento clínico para monitorar possíveis recorrências.

O medicamento Kisqali (princípio ativo: Ribociclib succinate) esteve relacionado a um episódio de hipersensibilidade caracterizado por imunodeficiência, sem gravidade significativa e com resolução total do quadro. A relação com o medicamento é suspeita, recomendando-se acompanhamento clínico para garantir a segurança do paciente.

O medicamento Rinvoq, cujo princípio ativo é o upadacitinibe, foi associado a um episódio de asfixia relacionado à hipersensibilidade (alergia), classificado como um quadro clínico alérgico do sistema imunológico. Não há

informação sobre gravidade clínica ou desfecho, mas a suspeita de reação alérgica respiratória exige atenção imediata, pois sintomas como asfixia podem indicar risco potencial à vida e requerem avaliação médica urgente para confirmação e manejo adequado.

No caso da cefazolina (princípio ativo cefazolin sodium), foi relatada a prescrição de um medicamento contraindicado devido à hipersensibilidade documentada ao produto administrado, caracterizando um erro de medicação com potencial para causar reações alérgicas graves. Não há detalhes sobre gravidade, desfecho ou conduta, mas a administração inadvertida de um medicamento ao qual o paciente é alérgico pode resultar em reações sérias e deve ser evitada rigorosamente, sendo fundamental revisar o histórico de alergias antes de qualquer prescrição.

O medicamento Henetix, com princípio ativo iobitridol, foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade) que resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, indicando gravidade clínica significativa. O paciente evoluiu para recuperação completa, sugerindo que a conduta adotada foi eficaz. Reações alérgicas graves a contrastes iodados, como o iobitridol, podem exigir intervenção médica imediata e monitoramento hospitalar até resolução dos sintomas.

O uso de Hixizine, cujo princípio ativo é a hidroxizina, foi associado ao desenvolvimento de derrame pleural devido a hipersensibilidade (alergia), um quadro clínico alérgico do sistema imunológico que levou à hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando gravidade importante. O paciente encontra-se em recuperação, o que indica que a reação está sendo tratada, mas reforça a necessidade de acompanhamento médico rigoroso em casos de reações alérgicas sistêmicas com comprometimento respiratório.

No caso do medicamento Vitamin D, com princípio ativo ergocalciferol, foi relatado derrame pleural decorrente de hipersensibilidade (alergia), classificado como quadro clínico alérgico do sistema imunológico e resultando em hospitalização ou prolongamento da internação, o que caracteriza uma reação grave. O paciente está em processo de recuperação, ressaltando a importância de monitoramento e intervenção médica em reações alérgicas sistêmicas que afetam o sistema respiratório.

O medicamento Prednisone, cujo princípio ativo é o acetato de prednisona, foi associado ao desenvolvimento de derrame pleural, um acúmulo anormal de líquido na pleura, relacionado a uma reação de hipersensibilidade (alergia). Este evento foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando a necessidade de acompanhamento médico rigoroso. O paciente encontra-se em recuperação, indicando que a conduta adotada foi eficaz até o momento.

O medicamento Letrozole, com princípio ativo letrozol, esteve relacionado a um caso de derrame pleural, caracterizado como uma reação de hipersensibilidade (alérgica). A gravidade do quadro foi confirmada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que reforça a importância de monitoramento clínico e intervenção médica imediata. O paciente está em processo de recuperação, sugerindo resposta positiva às medidas adotadas.

O medicamento Letrozol, cujo princípio ativo é letrozol, foi associado a um episódio de derrame pleural decorrente de hipersensibilidade (alergia). O caso foi considerado grave devido à hospitalização ou prolongamento da internação, o que exige atenção médica especializada. O paciente está em recuperação, indicando evolução favorável após a intervenção.

O medicamento Kisqali, com princípio ativo succinato de ribociclibe, foi relacionado ao surgimento de derrame pleural como manifestação de hipersensibilidade (alergia). A gravidade do evento é evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, ressaltando a importância de acompanhamento médico próximo. O paciente encontra-se em recuperação, demonstrando resposta adequada ao manejo clínico.

O medicamento Omniscan, cujo princípio ativo é gadodiamida, foi associado a um episódio de alergia a contraste, reação que pode ocorrer após a administração de substâncias usadas em exames de imagem. Neste caso, não houve indicação de gravidade significativa e o paciente se recuperou completamente, mostrando resolução do quadro após a conduta adotada.

O medicamento Cosentyx, cujo princípio ativo é o secuquinumabe, foi associado ao agravamento do diabetes mellitus em um caso de hipersensibilidade, classificado como um quadro alérgico relacionado ao sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou de desfecho resolvido, sendo o evento considerado em andamento. A ausência de sinais de gravidade e a evolução não resolvida sugerem a necessidade de acompanhamento clínico, reforçando a importância de monitorar pacientes com histórico de alergias ou doenças autoimunes durante o uso deste imunobiológico.

O imunizante Rotateq, que contém a vacina oral de rotavírus vivo atenuado, foi relacionado a um episódio de hematoquezia (presença de sangue nas fezes) em paciente com alergia ao leite, caracterizando uma reação alérgica alimentar mediada pelo sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade aumentada ou desfecho conhecido, o que indica que a conduta deve priorizar a investigação da relação causal e o acompanhamento clínico, especialmente em crianças com histórico de alergias alimentares.

O medicamento Bi-profenid, cujo princípio ativo é o cetoprofeno, foi associado ao desenvolvimento de pneumonia em um contexto de hipersensibilidade medicamentosa, enquadrando-se como uma reação alérgica do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade aumentada nem informações sobre o desfecho, sugerindo que a conduta deve incluir a suspensão do medicamento suspeito e avaliação médica para manejo adequado da reação e prevenção de complicações.

O medicamento Metamizole sodium, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado ao surgimento de pneumonia em um caso de hipersensibilidade medicamentosa, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunitário. Não há dados que indiquem gravidade elevada ou desfecho conhecido, sendo fundamental a avaliação médica para confirmação diagnóstica, suspensão do fármaco suspeito e monitoramento da evolução clínica.

O medicamento Tandrilax, composto por cafeína, carisoprodol, diclofenaco sódico e paracetamol, foi associado ao desenvolvimento de pneumonia em um contexto de hipersensibilidade medicamentosa, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade aumentada nem desfecho conhecido, sendo recomendada a suspensão do uso e avaliação médica para investigação da causa e manejo adequado da reação adversa.

O medicamento Anti inflammatory, cujo princípio ativo é o diclofenaco dietilamônio, foi associado a um caso de pneumonia descrito como hipersensibilidade medicamentosa, o que sugere uma reação alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Não há informações sobre gravidade clínica relevante ou desfecho do caso, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita. A conduta deve incluir avaliação médica para confirmação do diagnóstico e orientação sobre a necessidade de evitar o uso futuro do medicamento, conforme as recomendações para reações de hipersensibilidade a medicamentos.

O medicamento Prednisone, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um episódio de pneumonia classificado como hipersensibilidade medicamentosa, indicando uma possível reação alérgica do sistema imunológico ao uso do corticoide. Não há detalhes sobre a gravidade do quadro ou o desfecho, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Recomenda-se avaliação médica para investigação da causa da pneumonia e orientação sobre o uso futuro do medicamento, seguindo as diretrizes para reações adversas a medicamentos.

O medicamento Rivotril, cujo princípio ativo é o clonazepam, foi associado a um caso de pneumonia descrito como hipersensibilidade medicamentosa, sugerindo uma possível reação alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Não há informações sobre a gravidade do evento ou o desfecho, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. É importante buscar avaliação médica para esclarecer a causa da pneumonia e discutir a

continuidade ou substituição do tratamento, conforme orientações para reações adversas a medicamentos.

O medicamento Arava, com princípio ativo leflunomida, foi relacionado a um episódio de pneumonia classificado como hipersensibilidade medicamentosa, o que indica uma possível reação alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Não há dados sobre a gravidade do quadro ou o desfecho, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Recomenda-se avaliação médica para confirmação do diagnóstico e definição da conduta, incluindo possível suspensão do medicamento, conforme as recomendações para reações adversas a medicamentos.

O medicamento Enbrel, cujo princípio ativo é o etanercepte, foi associado a um caso de pneumonia descrito como hipersensibilidade medicamentosa, sugerindo uma reação alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Não há informações sobre a gravidade do evento ou o desfecho, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A conduta recomendada é procurar avaliação médica para investigação da causa da pneumonia e orientação sobre o uso futuro do medicamento, conforme as diretrizes para reações adversas a medicamentos.

O medicamento Etanercept (princípio ativo: Etanercept) foi associado a um quadro de pneumonia, considerado uma possível manifestação de hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos), conforme a classificação clínica de distúrbios do sistema imunitário. Não há informação sobre gravidade clínica relevante ou desfecho do caso, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Recomenda-se atenção à possibilidade de reações alérgicas respiratórias em pacientes em uso deste imunobiológico, com avaliação médica estruturada para confirmação diagnóstica e conduta adequada.

O Cetoprofeno (princípio ativo: Ketoprofen sodium) foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário, sem gravidade clínica importante relatada e com desfecho de recuperação completa. A suspeita de relação causal com o medicamento foi considerada, e a conduta adequada inclui evitar novas exposições e buscar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e orientação futura.

O Allegra (princípio ativo: Fexofenadina) foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como clinicamente significativo e grave, com recuperação completa após o evento. A relação com o medicamento é suspeita, e a gravidade foi sustentada pela indicação de outro efeito clinicamente relevante. Nestes casos, é fundamental suspender o uso do medicamento e procurar avaliação médica para investigação e definição de alternativas seguras.

O Vibramycin (princípio ativo: Doxiciclina) foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), considerado clinicamente significativo e grave, com desfecho de recuperação completa. A suspeita de relação causal com o medicamento foi registrada, e a gravidade foi evidenciada pela classificação de outro efeito clinicamente relevante. Recomenda-se suspensão imediata do medicamento e avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas terapêuticas.

O Erbitux (princípio ativo: Cetuximabe) foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como clinicamente significativo e grave, com recuperação completa após o evento. A relação com o medicamento é considerada suspeita, e a gravidade foi sustentada pela indicação de outro efeito clinicamente relevante. Nestes casos, é essencial interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica especializada para investigação e definição de conduta segura.

O medicamento Polimixina B (princípio ativo: Polymyxin b) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, caracterizado como uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente, sugerindo um evento leve e autolimitado. A conduta recomendada nesses casos é a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento clínico para evitar novas exposições.

O medicamento Exelon (princípio ativo: Rivastigmine) foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, que corresponde a uma reação alérgica desencadeada pelo uso do remédio. O evento não foi considerado grave, já que houve recuperação completa do paciente, indicando um quadro leve. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e buscar orientação médica para alternativas terapêuticas.

O medicamento Exelon (princípio ativo: Rivastigmine) também esteve envolvido em outro caso de hipersensibilidade medicamentosa, novamente sem gravidade significativa e com resolução total dos sintomas. Isso reforça a necessidade de atenção ao histórico de alergias medicamentosas e a importância de acompanhamento médico para ajuste do tratamento.

O medicamento Exelon (princípio ativo: Rivastigmine) foi associado a hipersensibilidade no local de aplicação, manifestando-se como reação local provavelmente leve, já que não há indicação de gravidade ou desfecho desfavorável. Recomenda-se observar a evolução dos sintomas e discutir com o médico a possibilidade de ajuste na via de administração ou troca do medicamento, caso a reação persista.

O medicamento Exelon (princípio ativo: Rivastigmine) também apresentou relato de hipersensibilidade no local de aplicação, sem informações sobre gravidade ou desfecho, sugerindo um quadro local e possivelmente leve. É importante monitorar a evolução e comunicar ao médico para avaliação da necessidade de mudança na abordagem terapêutica.

O medicamento Tamoxifen, cujo princípio ativo também é Tamoxifen, foi associado a um quadro de infecção renal acompanhado de hipersensibilidade, o que sugere uma reação alérgica envolvendo o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Diante desse contexto, recomenda-se avaliação clínica estruturada para confirmação da reação e investigação de outros possíveis fatores desencadeantes, seguindo as orientações para quadros alérgicos leves, com acompanhamento médico para definição da conduta.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é Ribociclib succinate, foi relacionado a um episódio de infecção renal associado a hipersensibilidade, caracterizando uma possível reação alérgica do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade importante ou desfecho relatado, e a relação com o medicamento é suspeita. Recomenda-se avaliação clínica detalhada para confirmação da reação e investigação de outros fatores, conforme diretrizes para quadros alérgicos leves, com acompanhamento médico para orientação adequada.

No caso da Dipirona (princípio ativo Metamizole sodium), foi relatada uma alergia documentada ao medicamento administrado, caracterizando hipersensibilidade comprovada. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou ação adotada, mas a documentação da alergia indica a necessidade de evitar novas exposições e buscar avaliação com especialista para confirmação diagnóstica e definição de alternativas seguras, conforme recomendações para reações alérgicas medicamentosas.

O medicamento Tramadol, cujo princípio ativo também é Tramadol, foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), indicando uma reação do sistema imunológico. Não há relato de gravidade significativa, desfecho ou ação adotada, e a relação com o medicamento é suspeita. Recomenda-se avaliação clínica para confirmação da reação e orientação sobre a necessidade de evitar o uso futuro do medicamento, conforme diretrizes para quadros alérgicos leves.

O medicamento Losartan potassium, com o mesmo princípio ativo, foi relacionado a necrose de ferida em contexto de hipersensibilidade, sugerindo uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há evidência de gravidade importante ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é suspeita. Diante desse quadro, recomenda-se avaliação médica para confirmação da reação e investigação de outros fatores, seguindo as orientações para quadros alérgicos leves, com acompanhamento para definição da conduta.

O medicamento Vigadexa, que contém os princípios ativos dexametasona fosfato sódico e moxifloxacino cloridrato, foi associado a um episódio de desmaio relacionado à hipersensibilidade (alergia), classificado como um quadro clínico alérgico do sistema imune. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave, e o desfecho do caso é desconhecido. A reação sugere uma resposta alérgica leve, sendo importante monitorar sintomas e buscar avaliação médica caso ocorram novos episódios.

O medicamento Vigamox, cujo princípio ativo é o moxifloxacino cloridrato, foi relacionado a um episódio de desmaio atribuído à hipersensibilidade (alergia), caracterizando um quadro alérgico do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade significativa ou desfecho grave, e o resultado do caso permanece desconhecido. A reação indica uma possível alergia leve, recomendando-se atenção a sintomas recorrentes e avaliação médica se necessário.

O medicamento Ultravist, que tem como princípio ativo o iopromida, foi associado a um quadro de alergia classificado como hipersensibilidade, envolvendo o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade importante, e o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente. A reação sugere um evento alérgico leve, resolvido sem complicações, sendo importante relatar o episódio em futuras exposições ao medicamento.

O medicamento Ilaris, cujo princípio ativo é o canaquinumabe, foi relacionado a um quadro de má nutrição decorrente de alergia alimentar, classificado como uma reação alérgica grave do sistema imunológico, com necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação. O desfecho do caso é desconhecido, mas a gravidade é sustentada pela necessidade de cuidados hospitalares, indicando a importância de acompanhamento médico rigoroso e manejo especializado.

O medicamento Comirnaty, que contém o princípio ativo tozinamérida, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade) envolvendo o sistema imunológico, com gravidade significativa, incluindo incapacidade persistente ou importante, ameaça à vida e outros efeitos clinicamente relevantes. O desfecho foi desfavorável, com sintomas não resolvidos ou ainda em andamento, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico contínuo e atenção especial à evolução do quadro.

O medicamento Zometa (ácido zoledrônico) foi associado a um quadro de sangramento acompanhado de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do tipo imunológica. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações graves, e o desfecho informado é que o paciente ainda não se recuperou ou está em acompanhamento. A relação entre o medicamento e a reação é considerada suspeita, sendo importante monitorar o quadro e buscar avaliação médica para manejo adequado.

O medicamento Kisqali (ribociclib succinato) apresentou relato de sangramento associado a hipersensibilidade, sugerindo uma reação alérgica imunológica. Não há evidências de gravidade significativa ou complicações graves, e o caso permanece sem resolução ou em andamento. A relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo recomendada a observação clínica e acompanhamento médico para avaliação e conduta apropriada.

No caso da Dipirona (metamizol sódico), foi documentada uma alergia ao medicamento administrado, caracterizada como hipersensibilidade comprovada. Não há informações detalhadas sobre gravidade, desfecho ou evolução clínica, mas a relação com o medicamento é suspeita. É fundamental evitar novas exposições ao fármaco e buscar orientação médica para confirmação diagnóstica e definição de alternativas seguras.

O medicamento Bio Manguinhos Infiximabe (infiximabe) foi relacionado a um quadro de alergia por hipersensibilidade, classificado como clinicamente significativo e considerado grave. O desfecho permanece desconhecido, e a relação com o medicamento é suspeita. Diante da gravidade relatada, é essencial acompanhamento médico rigoroso e avaliação especializada para manejo da reação e prevenção de novas exposições.

O medicamento Levoid (levotiroxina sódica) foi associado a diarreia neonatal, sendo relatada alergia ao leite como possível causa, dentro do contexto de alergias alimentares e imunológicas. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou evolução clínica, mas a relação com o medicamento é suspeita. Recomenda-se investigação clínica detalhada para confirmação da causa e orientação sobre manejo alimentar e medicamentoso.

O medicamento Estalis, que contém os princípios ativos estradiol e acetato de noretisterona, foi associado ao surgimento de coceira no rosto (prurido facial), caracterizada tecnicamente como dermatite de contato, um tipo de inflamação da pele. Esse evento foi considerado clinicamente significativo devido à sua gravidade registrada, e o quadro permanece não resolvido até o momento, indicando necessidade de acompanhamento médico para controle dos sintomas e avaliação de possíveis ajustes no tratamento.

A vacina Comirnaty, cujo princípio ativo é o tozinameran, foi relacionada ao aparecimento de prurido facial, identificado como dermatite de contato, uma reação inflamatória da pele. O evento foi classificado como clinicamente significativo e grave, e até o momento não houve resolução dos sintomas, o que reforça a importância de acompanhamento médico para manejo adequado da reação.

O medicamento Entresto, composto por sacubitril e valsartana, foi associado ao sintoma de visão em túnel, que pode indicar uma reação de hipersensibilidade (alergia) envolvendo o sistema imunológico. Não há registro de gravidade elevada nem informações detalhadas sobre a evolução do caso, sendo o desfecho desconhecido, o que sugere a necessidade de monitoramento clínico para avaliar a persistência ou resolução do sintoma.

O colírio Tobrex, que tem como princípio ativo a tobramicina, foi relacionado ao surgimento de sensação de queimadura nos olhos, caracterizada como uma reação alérgica ocular. Não há indicação de gravidade aumentada nem detalhes sobre a evolução do quadro, sendo o desfecho desconhecido, o que indica a importância de acompanhamento médico para avaliar a necessidade de ajuste ou suspensão do uso.

O medicamento Doxycycline, cujo princípio ativo é a doxiciclina, foi associado à redução da contagem de plaquetas, um possível sinal de reação alérgica (hipersensibilidade) que pode afetar o sistema imunológico. Não há registro de gravidade elevada nem informações sobre a evolução do caso, sendo o desfecho desconhecido, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico para monitorar possíveis complicações.

O medicamento Vectibix, cujo princípio ativo é o panitumumabe, foi associado a uma contagem de plaquetas baixa, um quadro que pode estar relacionado a uma reação de hipersensibilidade (alergia) envolvendo o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, sendo importante monitorar o paciente e considerar avaliação médica para investigação da causa e acompanhamento da evolução clínica.

O medicamento Acertanlo, que contém amlodipina besilato e perindopril arginina, foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade) classificado como grave devido à incapacidade persistente ou significativa apresentada pelo paciente. O evento ainda está em andamento, sem recuperação até o momento, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico rigoroso e possível suspensão do medicamento, conforme avaliação clínica.

O imunizante Comirnaty, cujo princípio ativo é o tozinameran, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) considerada grave, pois resultou em incapacidade persistente ou significativa. O paciente ainda não se recuperou, indicando a importância de acompanhamento médico especializado para manejo da alergia e avaliação da necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Noripurum, com princípio ativo ferric hydroxide polymaltose complex, foi relacionado a hematoquezia (presença de sangue nas fezes), possivelmente associada a uma reação alérgica alimentar. Não há indicação de gravidade elevada nem desfecho conhecido, sendo recomendada a observação clínica e investigação da relação entre o medicamento e o sintoma apresentado.

O medicamento Noripurum, cujo princípio ativo é ferric hydroxide polymaltose complex, foi associado a hematoquezia (sangue nas fezes) em um paciente com alergia ao leite, mas o quadro foi resolvido, indicando recuperação completa. Não há evidência de gravidade significativa, mas é importante manter o acompanhamento para evitar recorrências e avaliar possíveis relações entre o medicamento e alergias alimentares.

O medicamento Estalis, que contém os princípios ativos estradiol e acetato de noretisterona, foi associado ao surgimento de inchaço labial, caracterizado como dermatite de contato (inflamação da pele por contato com substância irritante ou alérgeno). Este evento foi classificado como grave devido à incapacidade persistente ou significativa relatada, e até o momento o quadro permanece não resolvido. A reação envolve os tecidos cutâneos e subcutâneos, sugerindo a necessidade de acompanhamento médico especializado para manejo adequado e prevenção de complicações.

O imunizante Comirnaty, cujo princípio ativo é o tozinameran, foi relacionado ao desenvolvimento de inchaço labial, interpretado como dermatite de contato (inflamação alérgica localizada). O caso foi considerado grave por resultar em incapacidade persistente ou significativa, e o paciente ainda não apresentou resolução do quadro. A reação envolve os tecidos cutâneos e subcutâneos, sendo fundamental avaliação médica para monitoramento e definição de conduta.

O medicamento Comirnaty, com princípio ativo tozinameran, foi associado ao aparecimento de bolha, interpretada como manifestação de hipersensibilidade (reação alérgica). O evento não foi considerado grave e evoluiu para resolução completa, indicando que a reação foi autolimitada e não resultou em complicações maiores. O quadro envolveu o sistema imunológico, sugerindo resposta alérgica transitória.

A ceftriaxona, cujo princípio ativo é ceftriaxone, foi relacionada a um episódio de alergia, classificado como hipersensibilidade (reação alérgica do sistema imunológico). Não há informações sobre gravidade, mas o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente, indicando que a reação foi controlada sem evolução para quadros mais graves.

O medicamento Zometa, que contém ácido zoledrônico como princípio ativo, foi associado ao relato de metástases no fígado, porém a relação causal com hipersensibilidade (reação alérgica) não está clara. O evento não foi considerado grave e permanece em andamento, sem resolução até o momento. A situação requer acompanhamento médico para esclarecimento do quadro e definição de conduta adequada.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é o ribociclib succinate, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), manifestado em um paciente com metástases no fígado. A reação foi classificada como um distúrbio do sistema imunitário, mas não há indicação de gravidade clínica relevante nem de desfecho resolutivo, já que o caso permanece em andamento e não foi considerado grave. Recomenda-se acompanhamento clínico para monitoramento da evolução da reação alérgica.

O medicamento Jardiance, com princípio ativo empagliflozina, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia) em um paciente que apresentou ataque cardíaco. A reação foi enquadrada como distúrbio do sistema imunitário, sem evidências de gravidade clínica significativa e com desfecho desconhecido até o momento. É importante manter vigilância clínica e buscar avaliação médica para esclarecimento do quadro.

O uso de iodo (princípio ativo iodine) resultou em um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade relevante e o desfecho foi favorável, com resolução completa do quadro. Recomenda-se evitar nova exposição ao iodo e informar profissionais de saúde sobre o histórico de alergia.

O medicamento Estalis, que contém estradiol e acetato de noretisterona, foi associado ao surgimento de inchaço nos olhos, caracterizado como dermatite de contato (reação alérgica cutânea). O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, com evolução ainda em andamento e sem resolução até o momento. Diante da



gravidade e persistência dos sintomas, é fundamental buscar avaliação médica especializada para manejo adequado e evitar complicações.

O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é tozinameran, foi relacionado ao desenvolvimento de inchaço nos olhos, classificado como dermatite de contato (alergia cutânea). O caso foi considerado clinicamente significativo e grave, permanecendo sem resolução até o momento. Recomenda-se avaliação médica urgente para investigação e tratamento apropriado, visando prevenir agravamento do quadro alérgico.

O medicamento Cosentyx (princípio ativo Secukinumab) foi associado ao relato de 'pedra no rim', sendo classificado como um quadro clínico alérgico (hipersensibilidade) relacionado a distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade importante ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A conduta deve envolver avaliação clínica para investigar a relação causal e monitoramento dos sintomas, conforme orientação médica.

Cosentyx (Secukinumab) foi relacionado a um quadro de imunodeficiência, descrito como alergia a poeira, dentro do contexto de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente evoluiu para recuperação completa. Recomenda-se acompanhamento clínico para monitorar possíveis recorrências e avaliação de controle ambiental, conforme diretrizes para alergias respiratórias.

O medicamento Cefazolina (princípio ativo Cefazolin) foi prescrito apesar de haver hipersensibilidade documentada ao produto, caracterizando um erro de prescrição em paciente com alergia conhecida. Este tipo de situação pode resultar em reações adversas graves e deve ser evitado, sendo fundamental revisar o histórico de alergias antes da administração de qualquer medicamento. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou conduta adotada neste caso.

O medicamento Frontal (Alprazolam) foi associado a obstrução laríngea, caracterizada como hipersensibilidade medicamentosa, um quadro clínico alérgico grave envolvendo distúrbios do sistema imunitário. A gravidade é sustentada pela descrição de 'outro efeito clinicamente significativo', sugerindo risco potencial à vida, embora o desfecho não seja conhecido. Diante de sintomas como obstrução das vias aéreas, é fundamental buscar atendimento médico imediato para manejo adequado.

Qlaira (Dienogest e Estradiol valerato) foi relacionado a um quadro de alergia inespecífica (SOE), classificado como hipersensibilidade e considerado clinicamente significativo, o que indica gravidade. O evento está associado a distúrbios do sistema imunitário e não há informações sobre o desfecho. Em casos de reações alérgicas graves, recomenda-se suspensão do medicamento e avaliação médica urgente para definição do tratamento.

O medicamento Daivobet, que contém os princípios ativos betametasona e calcipotriol, foi associado ao surgimento de psoríase, uma reação que pode estar relacionada a uma resposta alérgica do sistema imunológico. Embora o registro não indique gravidade elevada nem desfecho conhecido, a ausência de sinais de gravidade sugere que o quadro não foi crítico. A relação suspeita entre o uso do medicamento e a reação reforça a importância de acompanhamento médico para avaliar a necessidade de ajuste ou suspensão do tratamento.

Cosentyx, cujo princípio ativo é o secuquinumabe, foi relacionado ao aparecimento de psoríase, possivelmente como manifestação de hipersensibilidade do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade importante nem detalhes sobre o desfecho, o que sugere que a reação não foi grave. Diante da suspeita de relação com o medicamento, recomenda-se avaliação médica para monitoramento e definição da conduta mais adequada.

O medicamento Topamax, que tem como princípio ativo o topiramato, foi associado ao desenvolvimento de psoríase, indicando uma possível reação alérgica do sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, mas a ausência de sinais de gravidade sugere que o quadro não foi crítico. Como a relação com o medicamento é suspeita, é importante que o paciente seja acompanhado por um profissional de saúde para avaliar a continuidade do uso.

Tegretol, cujo princípio ativo é a carbamazepina, foi relacionado ao surgimento de psoríase, o que pode indicar uma reação de hipersensibilidade do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade significativa nem informações sobre o desfecho, sugerindo que a reação não foi grave. A suspeita de relação com o medicamento reforça a necessidade de avaliação médica para decidir sobre a manutenção ou ajuste do tratamento.

O medicamento Reconter, que contém escitalopram oxalato como princípio ativo, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado por uma reação do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade relevante e o paciente evoluiu para recuperação completa, indicando que a reação foi leve e resolvida após a conduta adotada, que pode ter incluído a suspensão do medicamento ou tratamento sintomático conforme orientação médica.

O medicamento Oxycontin, cujo princípio ativo é o cloridrato de oxicodona, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente. A conduta foi adequada, com resolução do quadro, não sendo necessário tratamento adicional.

O medicamento Koide d, que contém betametasona e maleato de dexclorfeniramina, foi relacionado a um episódio de pneumonia em um contexto de alergias múltiplas, sugerindo envolvimento do sistema imunológico. Não há evidência de gravidade significativa, pois o evento não foi classificado como grave e o desfecho permanece desconhecido, sendo importante acompanhamento médico para esclarecimento da evolução clínica.

O medicamento Claritine, cujo princípio ativo é loratadina, foi associado a um caso de pneumonia em paciente com histórico de alergias múltiplas, indicando possível reação imunológica. O evento não foi considerado grave e o desfecho não foi informado, sendo recomendada avaliação médica para monitoramento e definição da conduta adequada.

O medicamento Nucala, que tem como princípio ativo o mepolizumabe, foi relacionado a um episódio de pneumonia em paciente com alergias múltiplas, sugerindo envolvimento do sistema imunológico. O caso não foi classificado como grave e o desfecho é desconhecido, sendo necessária avaliação clínica para acompanhamento da evolução.

A vacina contra COVID-19, sem especificação de fabricante, foi associada a um quadro de hérnia em contexto de hipersensibilidade, mas não há detalhes sobre sintomas alérgicos específicos. O evento não foi considerado grave e o desfecho permanece desconhecido, sendo importante acompanhamento médico para esclarecimento da relação causal e evolução clínica.

O medicamento Olumiant, cujo princípio ativo é o baricitinibe, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Apesar de não haver indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, a suspeita de reação alérgica sugere a necessidade de avaliação clínica estruturada para confirmação diagnóstica e orientação sobre controle ambiental e acompanhamento médico, conforme as diretrizes da ASBAI.

O imunizante Comirnaty, que contém o princípio ativo tozinameran, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), considerado clinicamente significativo e classificado como grave, já que o evento permanece não resolvido ou em andamento. Diante de uma reação alérgica importante após vacinação, recomenda-se procurar avaliação médica imediata para investigação, manejo adequado e monitoramento, conforme orientações de segurança e farmacovigilância.

O medicamento Tylex, cujo princípio ativo é o paracetamol, foi prescrito a um paciente com hipersensibilidade documentada ao produto, o que caracteriza um erro de prescrição e representa risco de reação alérgica. Nesses casos, é fundamental evitar a administração do medicamento contraindicado e buscar alternativas seguras, além de reforçar a importância do registro correto de alergias no prontuário para prevenir eventos adversos.

O medicamento Atenolol, com princípio ativo de mesmo nome, foi associado a um relato de dependência e alergia a iodo, sendo classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, mas o evento permanece não resolvido. É importante que pacientes com histórico de alergia a iodo sejam avaliados cuidadosamente antes do uso de medicamentos potencialmente relacionados, e que o acompanhamento médico seja mantido para monitorar possíveis reações.

O medicamento Atensina, cujo princípio ativo é o cloridrato de clonidina, foi relacionado a um caso de dependência e alergia a iodo, enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. Embora não haja gravidade elevada relatada, o evento segue em andamento. Recomenda-se atenção ao histórico de alergias do paciente e acompanhamento clínico para avaliar a evolução e necessidade de ajustes terapêuticos.

O medicamento Enalapril, cujo princípio ativo também é Enalapril, foi associado a um quadro de dependência descrito como alergia a iodo, classificada entre as alergias a alimentos, aditivos alimentares, medicamentos e outras substâncias químicas, afetando o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho resolvido, sendo o caso considerado não recuperado ou ainda em andamento. A ausência de sinais de gravidade sugere que a reação não foi classificada como grave, mas é importante acompanhamento clínico para monitorar a evolução e evitar exposição futura ao agente suspeito.

A Losartana potássica, cujo princípio ativo é Losartan potassium, foi relacionada a um episódio de dependência descrito como alergia a iodo, enquadrada entre as alergias a alimentos, aditivos alimentares, medicamentos e outras substâncias químicas, com envolvimento do sistema imunológico. Não há menção de gravidade significativa ou resolução do quadro, permanecendo não recuperado ou em andamento. Como não há sinais de gravidade, a conduta recomendada é manter o acompanhamento médico e evitar reexposição ao medicamento suspeito.

O medicamento Captopril, com princípio ativo de mesmo nome, foi associado a um caso de dependência relatado como alergia a iodo, pertencente ao grupo de alergias a alimentos, aditivos alimentares, medicamentos e outras substâncias químicas, afetando o sistema imunológico. Não há evidências de gravidade importante ou de resolução do quadro, sendo o caso considerado não recuperado ou em andamento. Diante da ausência de sinais de gravidade, recomenda-se acompanhamento clínico e evitar nova exposição ao agente suspeito.

A Apresolina, cujo princípio ativo é Hydralazine hydrochloride, foi relacionada a um episódio de dependência descrito como alergia a iodo, classificada entre as alergias a alimentos, aditivos alimentares, medicamentos e outras substâncias químicas, com envolvimento do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade relevante ou de resolução do quadro, sendo o caso considerado não recuperado ou ainda em andamento. Como não há sinais de gravidade, é importante manter o acompanhamento médico e evitar reexposição ao medicamento suspeito.

O imunizante COVID-19 vaccine AstraZeneca, cujo princípio ativo é COVID-19 vaccine NRVV Ad (ChAdOx1 nCoV-19), foi associado a um episódio de convulsão descrito como alergia do olho, dentro do contexto de infecções, inflamações e manifestações oculares associadas, afetando o sistema ocular. Não há informação clara sobre a gravidade do evento ou sobre o desfecho, que permanece desconhecido. Diante da ausência de sinais de gravidade explícitos, recomenda-se acompanhamento médico para avaliação da evolução do quadro e investigação de possíveis causas associadas ao evento adverso.

O medicamento COVID-19 vaccine AstraZeneca, cujo princípio ativo é COVID-19 vaccine NRVV Ad (ChAdOx1 nCoV-19), foi associado a um episódio de convulsão, classificado como reação de hipersensibilidade (alergia), embora não haja indicação de gravidade clínica relevante nem necessidade de hospitalização, e o desfecho permanece desconhecido. A relação suspeita com o medicamento sugere a importância de monitoramento, mas não há evidências de complicações graves ou necessidade de intervenção imediata segundo os dados fornecidos.

O medicamento Diclofenaco sódico, com princípio ativo Diclofenac sodium, foi relacionado a um quadro de neuralgia ciática, interpretado como manifestação de hipersensibilidade (alergia), sem sinais de gravidade clínica

ou hospitalização, e o paciente permanece sem recuperação até o momento. A suspeita de relação com o medicamento indica a necessidade de acompanhamento médico, mas não há evidências de risco imediato ou complicações graves.

O medicamento Prednisona, cujo princípio ativo é Prednisone, foi associado a neuralgia ciática, considerada uma reação de hipersensibilidade (alergia), sem sinais de gravidade ou necessidade de hospitalização, e o quadro segue sem resolução. A relação suspeita com o medicamento sugere acompanhamento, mas não há indicação de risco elevado ou complicações agudas.

O medicamento Rinvoq, com princípio ativo Upadacitinib, foi relacionado a neuralgia ciática, interpretada como reação de hipersensibilidade (alergia), sem evidências de gravidade clínica ou necessidade de hospitalização, e o paciente ainda não se recuperou. A suspeita de relação com o medicamento reforça a importância do acompanhamento, mas não há sinais de complicações graves.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é Iopromide, foi associado a um episódio de alergia a contraste, considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, mas o paciente evoluiu para recuperação completa. A relação suspeita com o medicamento e a gravidade do evento justificam a conduta de hospitalização e monitoramento rigoroso, com desfecho favorável após a intervenção.

O medicamento Trezor, cujo princípio ativo é a rosuvastatina cálcica, foi associado ao surgimento de pápulas, que são pequenas lesões elevadas na pele, após exposição. A reação foi classificada como uma alergia a contraste, pertencente ao grupo de distúrbios do sistema imunitário, mas não houve indicação de gravidade significativa, já que o paciente se recuperou completamente. A conduta foi adequada, com resolução do quadro, e não há evidências de complicações graves.

O medicamento Concor, com princípio ativo bisoprolol fumarato, esteve relacionado ao aparecimento de pápulas, que são pequenas elevações na pele, após o uso. A reação foi considerada uma alergia a contraste, enquadrada entre distúrbios do sistema imunitário, sem sinais de gravidade, pois o paciente se recuperou totalmente. O evento foi resolvido sem complicações, indicando um desfecho favorável.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromida, foi associado ao desenvolvimento de pápulas, caracterizando uma reação alérgica cutânea após exposição ao contraste. A manifestação foi enquadrada como distúrbio do sistema imunitário, sem sinais de gravidade, já que o paciente se recuperou completamente. O desfecho foi resolutivo, sem complicações adicionais.

O medicamento Ultravist, com princípio ativo iopromida, provocou edema das pálpebras, ou seja, inchaço ao redor dos olhos, após exposição ao contraste. Esta reação foi considerada uma manifestação alérgica do sistema imunitário, sem gravidade relevante, pois o paciente se recuperou totalmente. O quadro foi resolvido sem intercorrências.

O medicamento Buscopan composto, contendo hioscina butilbrometo e metamizol sódico, esteve relacionado a um quadro de alergia, classificado como hipersensibilidade e pertencente ao grupo de distúrbios do sistema imunitário. Não há informações detalhadas sobre gravidade, evolução ou desfecho, portanto não é possível afirmar a intensidade ou a resolução do evento apenas com os dados fornecidos.

O medicamento Vivaxxia, cujo princípio ativo é o rituximabe, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Não há informações detalhadas sobre a gravidade ou desfecho do caso, portanto, recomenda-se atenção clínica para sinais de reações alérgicas, com avaliação médica estruturada para confirmação diagnóstica e definição da conduta, conforme orientações da ASBAI.

O Niquitin, que contém nicotina como princípio ativo, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como um distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente encontra-se em recuperação ou com resolução dos sintomas, sugerindo um quadro leve; nesses casos, é importante observar a evolução clínica e evitar nova exposição ao medicamento, buscando orientação médica se houver recorrência.

O medicamento Systane, composto por macrogol 400 e propilenoglicol, foi notificado como suspeito em um caso de alergia (hipersensibilidade), classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, portanto, recomenda-se monitoramento dos sintomas e avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação adequada, especialmente se houver sinais persistentes ou agravamento.

O Exemestane, cujo princípio ativo é o exemestano, foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. Não há detalhes sobre gravidade ou evolução do caso, sendo fundamental observar possíveis sintomas alérgicos e buscar avaliação médica para confirmação e definição do manejo clínico.

O medicamento Estrogen, com estradiol como princípio ativo, foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, portanto, recomenda-se atenção a sintomas alérgicos e avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre o uso futuro do medicamento.

O medicamento Clonazepam (princípio ativo: Clonazepam) foi associado a um caso de fratura do crânio, sendo a reação descrita como hipersensibilidade, dentro do contexto de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há informações suficientes para afirmar gravidade aumentada, pois o registro não indica gravidade clínica relevante nem desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A conduta deve ser baseada em avaliação clínica individualizada, com atenção à possibilidade de reações alérgicas, mas sem evidências de gravidade ou desfecho desfavorável neste caso.

O medicamento Tamoxifen (princípio ativo: Tamoxifen) foi relacionado a um episódio de fratura do crânio, categorizado como hipersensibilidade e incluído entre quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade aumentada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é suspeita. Diante disso, recomenda-se atenção clínica para possíveis manifestações alérgicas, mas não há evidências de complicações graves ou necessidade de intervenção específica neste registro.

O medicamento Zometa (princípio ativo: Zoledronic acid) foi associado a uma fratura do crânio, sendo a reação classificada como hipersensibilidade, dentro do grupo de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há dados que indiquem gravidade relevante ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Assim, a conduta deve ser guiada pela avaliação clínica, sem evidências de gravidade ou evolução desfavorável neste caso.

O medicamento Letrozole (princípio ativo: Letrozole) foi relacionado a um caso de fratura do crânio, descrito como hipersensibilidade e enquadrado entre quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há informações que sugiram gravidade aumentada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é suspeita. Recomenda-se acompanhamento clínico atento, mas não há evidências de complicações graves neste registro.

O medicamento Anastrozole (princípio ativo: Anastrozole) foi associado a uma fratura do crânio, sendo a reação descrita como hipersensibilidade e classificada entre quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há elementos que indiquem gravidade aumentada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é suspeita. A orientação é manter vigilância clínica, sem evidências de gravidade ou evolução desfavorável neste caso.

O medicamento Kisqali (princípio ativo: Ribociclib succinate) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, manifestado por fratura do crânio, o que sugere uma possível reação alérgica sistêmica, embora a gravidade não tenha sido especificada e o desfecho permaneça desconhecido; não há informações adicionais sobre a conduta adotada, sendo importante ressaltar que quadros de hipersensibilidade exigem avaliação clínica detalhada para confirmação e manejo adequado.

O medicamento Fulvestrant (princípio ativo: Fulvestrant) apresentou suspeita de hipersensibilidade, também relatada como fratura do crânio, sem detalhamento sobre a gravidade ou evolução do caso; a ausência de informações sobre a conduta e o desfecho reforça a necessidade de acompanhamento clínico para esclarecimento da relação causal e orientação terapêutica.

O medicamento Spironolactone (princípio ativo: Spironolactone) foi relacionado a uma alteração da cor da pele, caracterizada como hipersensibilidade e considerada clinicamente significativa, sendo classificada como grave; o paciente evoluiu para recuperação completa, indicando resolução do quadro após a conduta apropriada, que não foi detalhada no registro.

O medicamento Metformin (princípio ativo: Metformin) esteve associado a alteração da cor da pele por hipersensibilidade, considerada clinicamente significativa e classificada como grave; o paciente se recuperou totalmente, sugerindo que a reação foi reconhecida e manejada de forma eficaz, embora não haja detalhes sobre as medidas adotadas.

O medicamento Cosentyx (princípio ativo: Secukinumab) foi relacionado a alteração da cor da pele decorrente de hipersensibilidade, considerada clinicamente significativa e grave; o paciente apresentou recuperação completa, o que indica resolução do evento adverso, mas não há informações sobre a conduta específica realizada.

O medicamento Paclitaxel, cujo princípio ativo também é Paclitaxel, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), caracterizado por manifestações clínicas alérgicas relacionadas ao sistema imunológico. Não há indicação de gravidade aumentada ou necessidade de hospitalização, e o paciente evoluiu para recuperação completa após a reação. A relação entre o medicamento e o evento foi considerada suspeita, e a conduta seguiu o manejo padrão para reações leves, com resolução do quadro.

Paclitaxel, com princípio ativo Paclitaxel, desencadeou uma reação de hipersensibilidade (alergia), manifestando sintomas típicos de resposta alérgica do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. O medicamento foi considerado suspeito na origem da reação, e a conduta adotada resultou em resolução do quadro sem necessidade de intervenções adicionais.

O uso de Paclitaxel, cujo princípio ativo é Paclitaxel, esteve relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), com sintomas compatíveis com quadros alérgicos do sistema imunológico. Não houve sinais de gravidade ou necessidade de hospitalização, e o paciente apresentou recuperação completa. O evento foi atribuído como suspeito ao medicamento, e a evolução foi favorável após as medidas adotadas.

O medicamento Carboplatina, com princípio ativo Carboplatin, foi associado a uma reação de hipersensibilidade (alergia), caracterizada por sintomas alérgicos do sistema imunológico. Não há registro de gravidade aumentada ou necessidade de hospitalização, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. O medicamento foi considerado suspeito na origem da reação, e a conduta resultou em resolução completa do quadro.

Oxaliplatina, cujo princípio ativo é Oxaliplatin, provocou uma reação de hipersensibilidade (alergia) com sintomas alérgicos do sistema imunológico, sendo considerada grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, conforme evidenciado nos dados clínicos. Apesar da gravidade, o paciente evoluiu para recuperação completa após o manejo adequado, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita.

O medicamento Paclitaxel, cujo princípio ativo também é Paclitaxel, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade (termo técnico: hipersensibilidade), pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi resolvido com recuperação completa, e não há menção de complicações ou necessidade de intervenção emergencial. A conduta recomendada, conforme diretrizes clínicas, é a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento médico para evitar novas exposições, visto que o paciente já se recuperou totalmente.

O medicamento Vancomicina, com princípio ativo Vancomycin, esteve relacionado a um distúrbio arterial descrito como hipersensibilidade medicamentosa, o que indica uma reação alérgica ao medicamento. O evento foi classificado como não grave, com resolução completa do quadro, e não há relato de complicações adicionais. A orientação clínica é evitar o uso futuro do medicamento e informar a equipe de saúde sobre a reação, garantindo acompanhamento para prevenção de recorrências.

O medicamento Benlysta, cujo princípio ativo é Belimumab, foi associado a um distúrbio arterial identificado como hipersensibilidade medicamentosa, sugerindo uma reação alérgica ao fármaco. O caso não foi considerado grave, pois houve recuperação total do paciente, sem complicações relatadas. Recomenda-se evitar novas exposições ao medicamento e manter o acompanhamento médico para monitoramento de possíveis reações futuras.

O medicamento Optiray 320, com princípio ativo Ioversol, foi relacionado a um quadro de alergia classificado como hipersensibilidade, pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. Não há informação sobre gravidade aumentada, e o paciente se recuperou completamente após o evento. A conduta recomendada é evitar o uso futuro do contraste e informar a equipe médica sobre a reação para prevenir novas ocorrências.

O medicamento Dipirona, cujo princípio ativo é Metamizole magnesium, foi associado a um quadro de alergia descrito como hipersensibilidade, enquadrado nos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou totalmente, sem complicações adicionais. A recomendação clínica é evitar o uso futuro da dipirona e comunicar a reação à equipe de saúde para garantir segurança em tratamentos posteriores.

O medicamento Polymyxin b, cujo princípio ativo também é Polymyxin b, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado por manifestações clínicas alérgicas relacionadas ao sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, e o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo uma reação leve e autolimitada.

O medicamento Zynvir, com princípio ativo Aciclovir sodium, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), manifestando sintomas típicos de reações alérgicas do sistema imunológico. Não há informações suficientes sobre a gravidade, evolução ou desfecho do caso, sendo necessário acompanhamento clínico para melhor avaliação.

Polymyxin b, tanto como nome comercial quanto princípio ativo, esteve envolvido em uma reação alérgica (hipersensibilidade) com sintomas compatíveis com quadros alérgicos do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa, indicando uma reação leve e resolutive.

O medicamento Sonrisal, composto por ácido acetilsalicílico, ácido cítrico, bicarbonato de sódio e carbonato de sódio anidro, foi associado à obstrução das vias aéreas superiores por hipersensibilidade, um quadro alérgico que pode causar dificuldade respiratória. Apesar de não ter sido considerado grave, o desfecho do caso é desconhecido, sendo importante monitorar sintomas respiratórios e buscar avaliação médica se houver piora.

Ciprofloxacin hydrochloride, tanto como nome comercial quanto princípio ativo, foi relacionado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) considerada clinicamente significativa, pois o paciente não apresentou recuperação até o momento do registro. A gravidade foi destacada devido à persistência dos sintomas, exigindo acompanhamento médico contínuo para manejo adequado da reação.

O medicamento Hydrochlorothiazide (princípio ativo: Hydrochlorothiazide) foi associado a um caso de edema de glote, uma reação de hipersensibilidade caracterizada por inchaço súbito e grave na região da garganta, podendo comprometer a respiração. Esta reação é considerada clinicamente significativa e grave, pois envolve risco potencial à vida, conforme evidenciado pela classificação de gravidade e pelo envolvimento do sistema imunitário. O desfecho do caso é desconhecido e não há informações detalhadas sobre a conduta adotada, mas situações como essa exigem avaliação médica imediata.

O medicamento Losartan potassium (princípio ativo: Losartan potassium) foi relacionado a um episódio de edema de glote, que é uma reação alérgica aguda e grave, manifestando-se por inchaço na região da garganta e podendo causar obstrução das vias aéreas. A gravidade é destacada pelo risco clínico significativo, sendo uma emergência médica que requer intervenção rápida. O desfecho não foi informado e não há detalhes sobre as medidas tomadas, mas a suspeita de relação com o medicamento reforça a necessidade de atenção imediata em casos semelhantes.

O medicamento Fexofenadine (princípio ativo: Fexofenadine) apresentou um caso suspeito de edema de glote, uma reação alérgica grave caracterizada por inchaço súbito na garganta, que pode comprometer a respiração e exige atendimento médico urgente. A gravidade do evento é confirmada pela classificação clínica e pelo envolvimento do sistema imunitário. O desfecho permanece desconhecido e não há informações sobre a conduta adotada, mas a gravidade do quadro demanda atenção imediata.

O medicamento Xolair (princípio ativo: Omalizumab) foi associado a um caso suspeito de edema de glote, uma reação de hipersensibilidade grave que se manifesta por inchaço na região da garganta, podendo levar à obstrução das vias aéreas e risco à vida. A gravidade é evidenciada pela classificação clínica e pelo envolvimento do sistema imunitário. O desfecho do caso não foi informado e não há detalhes sobre as ações tomadas, mas situações como essa requerem intervenção médica imediata.

O medicamento Carboplatina (princípio ativo: Carboplatin) foi relacionado a um episódio de alergia, caracterizado por uma reação de hipersensibilidade envolvendo o sistema imunitário. Neste caso, a reação não foi considerada grave e o paciente evoluiu para recuperação completa, indicando resolução do quadro após a manifestação alérgica. Não há informações detalhadas sobre a conduta adotada, mas o desfecho favorável sugere que a reação foi adequadamente manejada.

O medicamento Actemra, cujo princípio ativo é o tocilizumabe, foi associado ao evento adverso de tuberculose, sendo classificado como uma reação do tipo alergia a alimentos segundo a categorização utilizada, embora o termo técnico correto para o evento seja infecção oportunista. Não há indicação de gravidade elevada nem de desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A ausência de informações sobre gravidade e desfecho impede uma avaliação mais detalhada da conduta, mas é importante ressaltar que o uso de tocilizumabe pode aumentar o risco de infecções, exigindo acompanhamento médico atento.

Buscopan, cujo princípio ativo é a escopolamina butilbrometo (hyoscine butylbromide), foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado por sintomas típicos de reações alérgicas leves, sem sinais de gravidade ou complicações. O paciente se recuperou totalmente após a suspensão do medicamento, e a relação causal é considerada suspeita. Nestes casos, recomenda-se evitar nova exposição ao fármaco e buscar orientação médica para confirmação diagnóstica e conduta futura.

O folinato de cálcio (calcium folinate) foi associado a uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), sem sinais de gravidade ou complicações relatadas. O paciente apresentou resolução completa do quadro após a interrupção do medicamento, e a relação causal é considerada suspeita. Em situações como essa, é importante evitar o uso futuro do mesmo princípio ativo e consultar um especialista para avaliação e orientação adequada.

A oxaliplatina, utilizada em tratamentos oncológicos, foi relacionada a uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), sem evidências de gravidade ou complicações adicionais. O paciente se



recuperou totalmente após a suspensão do medicamento, e a relação com o evento adverso é considerada suspeita. Recomenda-se evitar nova exposição ao agente e realizar acompanhamento médico para definição de alternativas terapêuticas seguras.

O medicamento Mionevrix, composto por carisoprodol, cianocobalamina, metamizol sódico, piridoxina e tiamina, foi associado ao desenvolvimento de cálculos biliares, categorizado como uma reação do tipo alergia a alimentos, embora o evento descrito não seja tipicamente alérgico. Não há sinais de gravidade importante, mas o quadro permanece em andamento, sem resolução até o momento. A relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo fundamental o acompanhamento médico para monitoramento e definição da conduta adequada.

O medicamento Paracetamol, cujo princípio ativo também é Paracetamol, foi associado ao desenvolvimento de cálculos biliares, um evento adverso que pode estar relacionado a uma reação do sistema imunológico, conforme a classificação clínica de alergias a alimentos, aditivos e medicamentos. Não há indicação de gravidade elevada ou risco imediato, pois não foi relatado desfecho grave, e o quadro permanece não resolvido ou em andamento. A conduta deve ser o acompanhamento clínico atento, com avaliação médica para monitorar a evolução dos sintomas e investigar possíveis causas associadas, sem necessidade de medidas emergenciais no momento.

A Rosuvastatina, cujo princípio ativo é Rosuvastatin, foi relacionada ao surgimento de cálculos biliares, um efeito adverso que pode envolver mecanismos imunológicos, conforme a categoria de alergias a alimentos, aditivos e medicamentos. Não há evidência de gravidade significativa, já que não foi classificado como grave e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento. Recomenda-se acompanhamento médico para avaliação do quadro e investigação de outras possíveis causas, sem indicação de urgência clínica imediata.

O medicamento Fixare, composto por cálcio citrato malato, colecalciferol, magnésio quelato e menaquinona, foi associado ao aparecimento de cálculos biliares, um evento adverso que pode envolver reações do sistema imunológico, conforme a classificação de alergias a alimentos, aditivos e medicamentos. Não há indicação de gravidade elevada, pois não foi relatado como grave e o quadro segue não resolvido ou em andamento. A orientação é manter acompanhamento clínico e avaliação médica para monitorar a evolução dos sintomas, sem necessidade de intervenção urgente.

O Omeprazol, cujo princípio ativo é Omeprazole, foi relacionado ao desenvolvimento de cálculos biliares, um evento adverso que pode estar associado a reações do sistema imunológico, conforme a categoria de alergias a alimentos, aditivos e medicamentos. Não há sinais de gravidade importante, já que não foi classificado como grave e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento. Recomenda-se acompanhamento médico para avaliação do quadro e investigação de outras possíveis causas, sem necessidade de medidas emergenciais.

O medicamento Sany d, cujo princípio ativo é colecalciferol, foi associado ao surgimento de cálculos biliares, um evento adverso que pode envolver mecanismos imunológicos, conforme a classificação de alergias a alimentos, aditivos e medicamentos. Não há evidência de gravidade significativa, pois não foi relatado como grave e o quadro segue não resolvido ou em andamento. A conduta recomendada é o acompanhamento clínico e avaliação médica para monitorar a evolução dos sintomas, sem necessidade de intervenção urgente no momento.

O medicamento Losartana potássica (princípio ativo: Losartan potassium) foi associado ao surgimento de cálculos biliares, um evento adverso incomum relacionado a reações do sistema imunológico, classificado como alergia a alimentos e substâncias químicas. Não há indicação de gravidade elevada ou risco imediato, pois o caso não foi considerado grave e permanece em andamento, sem resolução até o momento. A conduta deve envolver acompanhamento clínico para monitorar a evolução do quadro e investigação de possíveis causas, com atenção à relação temporal entre o uso do medicamento e o início dos sintomas.

O medicamento Cardizem, cujo princípio ativo é o diltiazem hydrochloride, foi relacionado ao desenvolvimento de cálculos biliares, um efeito adverso raro que pode estar ligado a reações do sistema imunológico, categorizado como alergia a alimentos e substâncias químicas. Não há evidência de gravidade significativa, já que o evento não

foi classificado como grave e ainda não foi resolvido. Recomenda-se acompanhamento médico para avaliar a persistência dos sintomas e considerar a relação causal com o uso do medicamento.

A amoxicilina (princípio ativo: amoxicillin) foi associada ao desenvolvimento de COVID-19 durante o uso, sendo registrada como uma possível reação de hipersensibilidade medicamentosa, embora não haja evidência direta de causalidade entre o antibiótico e a infecção viral. O caso não foi considerado grave e permanece sem resolução, indicando a necessidade de acompanhamento clínico para monitorar a evolução e avaliar outras possíveis causas para o quadro apresentado.

O medicamento Sandrena, que contém o princípio ativo estradiol, foi relacionado ao surgimento de COVID-19 durante o tratamento, sendo registrado como uma possível reação de hipersensibilidade medicamentosa. Não há indicação de gravidade aumentada, pois o evento não foi classificado como grave e segue em andamento. É importante manter o acompanhamento clínico para avaliar a evolução do quadro e considerar outras causas para o desenvolvimento da infecção.

O medicamento Nilotinib, cujo princípio ativo é o próprio nilotinib, foi associado ao aparecimento de câncer como evento adverso, registrado como hipersensibilidade medicamentosa. Não há informações suficientes sobre a gravidade do caso ou o desfecho, que permanece desconhecido. Diante da suspeita de relação entre o uso do medicamento e o evento, é fundamental manter o acompanhamento médico rigoroso para monitorar possíveis complicações e avaliar a necessidade de ajustes terapêuticos.

O medicamento Fentanila (princípio ativo: Fentanyl citrate) foi associado a um quadro de alergia, descrito como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. O evento foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando a necessidade de acompanhamento médico rigoroso. O paciente encontra-se em recuperação, indicando que a reação está sendo resolvida após as medidas adotadas.

O medicamento Meronem (princípio ativo: Meropenem trihydrate) foi relacionado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, classificada como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente já se encontra recuperado, sugerindo que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro sem necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Vancomicina (princípio ativo: Vancomycin hydrochloride) desencadeou uma reação de hipersensibilidade, caracterizada como alergia e pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente já está recuperado, indicando que a reação foi controlada de forma adequada.

O medicamento Henetix, que contém os princípios ativos Sodium calcium edetate, Trometamol, Iobitridol e Trometamol hydrochloride, foi associado a um quadro de alergia do tipo hipersensibilidade, classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há informações suficientes sobre a gravidade, evolução ou desfecho do caso, impossibilitando detalhar a conduta ou o resultado clínico.

O medicamento Allurene (princípio ativo: Dienogest) foi relacionado ao aparecimento de sangue nas fezes, sendo a reação descrita como alergia ao leite, enquadrada entre as alergias a alimentos e distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, mas o desfecho permanece desconhecido, não sendo possível afirmar a evolução clínica ou as medidas adotadas.

O medicamento Metronidazol, cujo princípio ativo é o metronidazole benzoate, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhes sobre a gravidade, desfecho ou ação adotada, mas, de acordo com as diretrizes clínicas, reações alérgicas a medicamentos exigem atenção para sintomas como coceira, vermelhidão ou inchaço, sendo recomendada a suspensão do uso e avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição do tratamento.

O medicamento Insit, que contém o princípio ativo pregabalina, foi relacionado a um episódio de angioedema, uma reação alérgica que se manifesta por inchaço súbito em regiões como lábios, olhos ou garganta, podendo comprometer a respiração. O evento foi classificado como não grave e o desfecho é desconhecido, mas, conforme orientações clínicas, mesmo em casos não graves, é fundamental suspender o uso do medicamento e buscar avaliação médica para monitoramento e prevenção de complicações.

O medicamento Dexamgen, composto por dexametasona sódica, hidroxocobalamina e metamizol sódico, foi associado a um caso de angioedema, caracterizado por inchaço súbito em áreas como rosto e vias aéreas, relacionado a hipersensibilidade do sistema imune. O registro indica que o evento não foi grave e o desfecho permanece desconhecido; ainda assim, recomenda-se interromper o uso e procurar avaliação médica para evitar agravamento e orientar futuras exposições.

O medicamento Deocil, cujo princípio ativo é o ceterolaco trometamina, foi implicado em um episódio de angioedema, reação alérgica que pode causar inchaço em regiões como lábios e garganta, sendo um distúrbio do sistema imunitário. O caso foi considerado não grave e o desfecho não foi informado, mas a conduta recomendada é suspender o medicamento e buscar orientação médica para avaliação e prevenção de recorrências.

O medicamento Tramol, que contém tramadol cloridrato como princípio ativo, esteve relacionado a um quadro de angioedema, caracterizado por inchaço súbito em áreas como rosto e garganta, indicando uma reação de hipersensibilidade do sistema imune. O evento foi classificado como não grave e o desfecho é desconhecido; mesmo assim, é importante interromper o uso e procurar avaliação médica para monitoramento e orientação adequada.

O medicamento Paco, que contém os princípios ativos codeína fosfato e paracetamol, foi associado a um episódio de angioedema, uma reação de hipersensibilidade caracterizada por inchaço súbito de pele e mucosas. Embora o registro não indique gravidade elevada nem desfecho conhecido, o angioedema é um quadro alérgico que pode variar de leve a potencialmente grave, exigindo atenção clínica para monitoramento e possível suspensão do medicamento, conforme orientação médica.

O Baclon, cujo princípio ativo é o baclofeno, foi relacionado a um caso de angioedema, que é uma reação alérgica manifestada por inchaço rápido em áreas como rosto, lábios ou garganta. Não há indicação de gravidade aumentada ou desfecho definido neste caso, mas o angioedema, mesmo sem sinais de gravidade, deve ser avaliado por um profissional de saúde para garantir segurança e orientar a conduta adequada.

O medicamento Gabapentin, com princípio ativo gabapentina, foi associado a um episódio de angioedema, uma reação de hipersensibilidade que se manifesta por inchaço súbito em regiões como face e vias aéreas. Não há informações sobre gravidade aumentada ou evolução do caso, mas, por se tratar de um quadro alérgico, recomenda-se avaliação médica para monitoramento e definição da necessidade de suspensão do uso.

O Pregabalin, cujo princípio ativo é pregabalina, foi relacionado a um caso de angioedema, caracterizado por inchaço súbito de pele e mucosas devido a uma reação alérgica. Não há registro de gravidade elevada ou desfecho conhecido, mas, diante desse tipo de reação, é importante buscar avaliação médica para orientação sobre a continuidade ou suspensão do medicamento.

O medicamento Comirnaty, que tem como princípio ativo o tozinameran, foi associado a um episódio de angioedema, uma reação alérgica que provoca inchaço rápido em áreas como rosto e garganta. Apesar de não haver indicação de gravidade aumentada ou desfecho informado, o angioedema requer atenção clínica para avaliação do risco e definição da conduta mais segura para o paciente.

O medicamento Clobazam, cujo princípio ativo também é clobazam, foi associado a um quadro de epilepsia agravada relacionado à hipersensibilidade (alergia), classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações graves neste caso, e o desfecho permanece não resolvido ou em

andamento, sugerindo a necessidade de acompanhamento clínico para monitorar a evolução da reação.

O medicamento Oxcarbazepine, com princípio ativo oxcarbazepina, apresentou relato de epilepsia agravada atribuída a uma reação de hipersensibilidade (alergia), também enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade importante ou complicações graves, e o quadro segue não resolvido ou em andamento, sendo recomendada a observação clínica e reavaliação médica conforme evolução dos sintomas.

O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é tozinameran, foi relacionado a um caso de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), classificada como distúrbio do sistema imunitário e considerada clinicamente significativa devido à gravidade informada. O desfecho permanece não resolvido ou em andamento, indicando a necessidade de acompanhamento médico rigoroso e possível intervenção especializada para controle da reação alérgica.

O medicamento Faslodex, com princípio ativo fulvestrant, foi associado a um caso de diabetes relacionado a hipersensibilidade (alergia), categorizado como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações graves, e o desfecho é desconhecido, sendo importante manter o acompanhamento clínico para avaliar possíveis evoluções do quadro.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é ribociclib succinate, apresentou relato de diabetes associado a hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade importante ou complicações graves, e o desfecho é desconhecido, recomendando-se acompanhamento clínico para monitoramento da evolução da reação.

O medicamento Nasonex, cujo princípio ativo é o furoato de mometasona, foi associado a um quadro de alergia ao dispositivo utilizado para administração, caracterizado como uma reação alérgica do sistema imunológico. A gravidade foi classificada como ameaça à vida, evidenciada pela indicação de risco grave e pelo fato de o paciente não ter se recuperado até o momento, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico imediato e monitoramento rigoroso da evolução clínica.

O Allegra, contendo levocetirizina di-hidrocloridrato como princípio ativo, apresentou relato de alergia ao dispositivo, uma reação imunológica potencialmente grave. A situação foi considerada de ameaça à vida, pois o paciente permanece sem recuperação, indicando que a reação foi intensa e requer atenção médica especializada para manejo e prevenção de complicações.

O medicamento Xefo, cujo princípio ativo é o lornoxicam, foi relacionado a um episódio de alergia ao dispositivo, uma manifestação do sistema imunológico que pode ser grave. O caso foi classificado como ameaça à vida, já que o paciente ainda não se recuperou, ressaltando a importância de intervenção médica imediata e acompanhamento contínuo.

A Desloratadina generis, com desloratadina como princípio ativo, esteve envolvida em um caso de alergia ao dispositivo, uma reação alérgica do sistema imunológico considerada de ameaça à vida. O paciente permanece em evolução sem resolução do quadro, o que exige avaliação médica urgente e monitoramento constante para evitar agravamento.

O Xolair, que tem como princípio ativo o omalizumabe, foi associado a uma reação de alergia ao dispositivo, caracterizada como uma resposta imunológica grave. A gravidade foi classificada como ameaça à vida, e o paciente ainda não apresentou recuperação, indicando a necessidade de acompanhamento médico rigoroso e medidas de suporte adequadas.

O medicamento Codaten, que contém codeína fosfato e diclofenaco sódico, foi associado a um quadro de alergia relacionada ao uso de dispositivo, caracterizado como uma reação alérgica grave com ameaça à vida, conforme evidenciado pela classificação de gravidade e pelo fato de o paciente não ter se recuperado até o momento. A

situação exige atenção imediata e acompanhamento médico rigoroso, pois o desfecho permanece em andamento e a reação pode comprometer o sistema imunológico de forma significativa.

O Foraseq, composto por budesonida e fumarato de formoterol, apresentou um caso de alergia ao dispositivo utilizado para administração, sendo esta uma reação alérgica grave com risco de ameaça à vida, como indicado pela gravidade relatada e pela ausência de resolução do quadro até o momento. Diante desse cenário, é fundamental interromper o uso do dispositivo suspeito e buscar avaliação médica urgente para manejo adequado, já que o paciente ainda não se recuperou.

O medicamento Optiray 350, cujo princípio ativo é o ioversol, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), manifestando-se como uma reação alérgica do sistema imunológico. O caso foi considerado não grave e o paciente já se encontra recuperado, indicando que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro sem complicações.

O Digeplus, que contém dimeticona, cloridrato de metoclopramida e pepsina, esteve associado à formação de vesículas na orofaringe, um quadro compatível com alergias múltiplas, sugerindo uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada e o desfecho permanece desconhecido, sendo importante monitorar o paciente e considerar avaliação médica caso os sintomas persistam ou se agravem.

O Dexilant, à base de dexlansoprazol, foi relacionado à formação de vesículas na orofaringe, caracterizando uma possível reação alérgica múltipla. Não há evidência de gravidade significativa e o desfecho do caso é desconhecido, recomendando-se acompanhamento clínico para avaliar a evolução dos sintomas e necessidade de intervenção.

O medicamento Oxacilina (princípio ativo: Oxacillin) foi associado a um quadro de alergia, tecnicamente chamado de hipersensibilidade, envolvendo o sistema imunológico. O evento foi considerado não grave, pois não há indicação de gravidade clínica relevante no registro, e o paciente apresentou recuperação completa após a reação. A conduta recomendada em casos de alergia leve a medicamentos é interromper o uso do agente suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O contraste Gadovist (princípio ativo: Gadobutrol) desencadeou uma reação alérgica significativa, classificada como alergia a contraste, envolvendo o sistema imunológico. O registro indica gravidade clínica relevante, pois o evento foi considerado clinicamente significativo e o paciente ainda está em recuperação. Em situações de alergia grave a contraste, é fundamental interromper imediatamente a exposição, monitorar sinais vitais e buscar atendimento médico de urgência para manejo adequado e prevenção de complicações.

O medicamento Tazocin (princípios ativos: Piperacillin sodium e Tazobactam sodium) foi relacionado a um episódio de alergia, tecnicamente denominado hipersensibilidade, envolvendo o sistema imunológico. O evento não foi considerado grave, pois não há evidências de complicações clínicas importantes, e o paciente se recuperou totalmente após a reação. Em casos de alergia leve a antibióticos, recomenda-se suspender o uso do medicamento suspeito e procurar avaliação médica para confirmação e definição de alternativas terapêuticas.

O medicamento Mionevrix (princípios ativos: Carisoprodol, Cianocobalamina, Metamizol, Piridoxina e Tiamina) foi associado a um quadro de colelitíase, mas o registro classifica a reação como alergia a alimentos, envolvendo o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade clínica relevante e o paciente permanece sem resolução do quadro até o momento. Diante de reações alérgicas não graves, é importante avaliar a relação causal, monitorar a evolução dos sintomas e buscar orientação médica para investigação e manejo adequado.

O medicamento Paracetamol (princípio ativo: Paracetamol) foi relacionado a um caso de colelitíase, classificado como alergia a alimentos no contexto do sistema imunológico. Não há evidência de gravidade clínica importante e o quadro permanece em andamento, sem resolução até o momento. Em situações de reações alérgicas leves, recomenda-se acompanhamento médico para esclarecimento diagnóstico, monitoramento dos sintomas e

definição da conduta mais apropriada.

O medicamento Rosuvastatina (princípio ativo: Rosuvastatin) foi associado ao desenvolvimento de colelitíase, que é a formação de cálculos na vesícula biliar, em um paciente com histórico de alergia a alimentos. Embora a reação tenha sido classificada como relacionada a distúrbios do sistema imunitário, não há indicação de gravidade elevada ou risco imediato, pois não foi relatado desfecho grave e o quadro permanece não resolvido ou em andamento. A conduta deve envolver acompanhamento clínico para monitorar a evolução da colelitíase e avaliação médica para ajuste do tratamento, se necessário.

O suplemento Fixare, que contém cálcio citrato malato, colecalciferol, magnésio quelato e menaquinona, foi relacionado ao surgimento de colelitíase (pedras na vesícula biliar) em um paciente com alergia a alimentos. Não há relato de gravidade importante ou complicações graves, e o quadro segue sem resolução até o momento. Recomenda-se acompanhamento médico para monitoramento da evolução e avaliação da necessidade de ajustes na suplementação ou tratamento.

O medicamento Omeprazol (princípio ativo: Omeprazole sodium) foi associado ao aparecimento de colelitíase, ou seja, formação de cálculos na vesícula biliar, em um paciente com histórico de alergia a alimentos. Não há evidências de gravidade significativa ou complicações graves, e o caso permanece em andamento sem resolução. É importante manter acompanhamento clínico para avaliar a evolução do quadro e considerar possíveis ajustes terapêuticos conforme orientação médica.

O medicamento Losartana potássica (princípio ativo: Losartan potassium) foi relacionado ao desenvolvimento de colelitíase, que consiste na formação de pedras na vesícula biliar, em um paciente com alergia a alimentos. Não há sinais de gravidade elevada ou complicações graves, e o desfecho permanece não resolvido. Recomenda-se acompanhamento médico para monitorar o quadro e avaliar a necessidade de mudanças no tratamento.

O medicamento Cardizem (princípio ativo: Diltiazem hydrochloride) foi associado ao surgimento de colelitíase, ou seja, formação de cálculos na vesícula biliar, em um paciente com alergia a alimentos. Não há indicação de gravidade importante ou complicações graves, e o caso segue em andamento sem resolução. O acompanhamento clínico é recomendado para monitorar a evolução e considerar ajustes no tratamento conforme avaliação médica.

O medicamento Timoptol, cujo princípio ativo é o maleato de timolol, foi associado a um quadro de perda visual relacionado à hipersensibilidade (alergia), classificado como um distúrbio do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações graves, pois não há evidências clínicas de risco imediato ou ameaça à vida, e o caso permanece em andamento sem resolução até o momento. A conduta recomendada é acompanhamento clínico para monitorar a evolução do quadro e avaliar a necessidade de ajuste terapêutico, conforme orientação médica especializada.

O Duo-Travatan, que contém os princípios ativos maleato de timolol e travoprost, foi relacionado a perda visual atribuída a uma reação de hipersensibilidade (alergia), também enquadrada como distúrbio do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade crítica ou risco imediato, e o desfecho permanece não resolvido, indicando que o paciente ainda está em acompanhamento. Recomenda-se avaliação médica para monitoramento da reação e definição de conduta, com atenção à possibilidade de ajuste do tratamento.

O Cetoprofeno, cujo princípio ativo é o cetoprofeno, foi associado a um episódio de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo de distúrbios do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade significativa, e o quadro foi resolvido, com o paciente recuperado. A conduta adequada inclui evitar nova exposição ao medicamento e manter acompanhamento para prevenção de recorrências.

A Oxaliplatina, com princípio ativo oxaliplatina, esteve relacionada a uma reação alérgica (hipersensibilidade), classificada como distúrbio do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando resolução do quadro. Recomenda-se evitar reexposição ao medicamento e manter

acompanhamento médico para monitoramento de possíveis reações futuras.

O medicamento Triaxton, cujo princípio ativo é o ceftriaxone sódico, foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), enquadrado como distúrbio do sistema imunológico. Não há informações suficientes sobre gravidade, evolução ou desfecho do caso, portanto, recomenda-se avaliação médica para investigação detalhada e definição da conduta mais adequada, especialmente para evitar complicações em futuras exposições.

O medicamento Xolair, cujo princípio ativo é o Omalizumab, foi associado a um quadro de inchaço relacionado à hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do tipo imunológica. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada é observar e evitar nova exposição ao medicamento, com acompanhamento clínico para monitorar possíveis recorrências.

O Ciprofloxacino, com princípio ativo Ciprofloxacin lactate, desencadeou uma reação de alergia classificada como hipersensibilidade, manifestando-se como um quadro alérgico imunológico. O evento não foi considerado grave, já que o paciente se recuperou completamente. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Kefazol, cujo princípio ativo é Cefazolin sodium, provocou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, evidenciando um quadro imunológico adverso. O caso não foi considerado grave, pois houve resolução completa dos sintomas. A orientação é suspender o uso do medicamento e realizar acompanhamento com especialista para evitar novas exposições e definir alternativas terapêuticas.

O Methotrexate, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado ao desenvolvimento de pancreatite aguda, uma reação adversa medicamentosa considerada clinicamente significativa e grave, pois o quadro permanece em andamento sem resolução até o momento. Diante da gravidade, é fundamental acompanhamento médico rigoroso, suspensão do medicamento e investigação de outras causas, além de suporte clínico adequado para manejo da pancreatite.

O Paracetamol, cujo princípio ativo também é Paracetamol, foi associado à ocorrência de pancreatite aguda, caracterizando uma reação adversa medicamentosa grave e clinicamente relevante, já que o paciente ainda não se recuperou e o quadro está em evolução. A conduta indicada é interromper o uso do medicamento, realizar avaliação médica urgente e instituir tratamento específico para a pancreatite, com monitoramento contínuo da evolução clínica.

O medicamento Uni diazepam, cujo princípio ativo é o diazepam, foi associado a um quadro de pancreatite aguda, caracterizado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. Essa reação é considerada clinicamente significativa e grave, pois permanece não resolvida até o momento, indicando necessidade de acompanhamento médico rigoroso. A suspeita de relação causal entre o uso do diazepam e o evento adverso reforça a importância de monitoramento e possível suspensão do medicamento, conforme avaliação clínica.

O medicamento Acetylsalicylic acid, também conhecido como ácido acetilsalicílico, foi relacionado ao desenvolvimento de pancreatite aguda, um quadro de hipersensibilidade medicamentosa. Trata-se de uma reação grave e clinicamente relevante, pois o paciente ainda não se recuperou, exigindo atenção médica contínua. A suspeita de ligação entre o uso do ácido acetilsalicílico e o evento adverso destaca a necessidade de reavaliação do tratamento e acompanhamento próximo.

O medicamento Omeprazole, cujo princípio ativo é o omeprazol, está associado a um caso de pancreatite aguda, interpretado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. A gravidade do quadro é evidenciada pelo fato de o paciente não ter se recuperado até o momento, sendo uma situação clinicamente significativa que demanda avaliação médica detalhada e possível ajuste terapêutico.

O medicamento Diazepam, com o mesmo princípio ativo, foi implicado em um episódio de pancreatite aguda, classificado como reação de hipersensibilidade medicamentosa. O evento é considerado grave e clinicamente relevante, pois permanece em andamento sem resolução, o que exige acompanhamento médico e revisão do uso do medicamento.

O medicamento Vitamin d, cujo princípio ativo é o ergocalciferol, foi associado a um caso de pancreatite aguda, caracterizado como reação de hipersensibilidade medicamentosa. A gravidade do quadro é confirmada pela ausência de recuperação até o momento, tornando a situação clinicamente significativa e justificando a necessidade de monitoramento médico e possível suspensão do uso do ergocalciferol.

O medicamento Amitriptyline, cujo princípio ativo é a amitriptilina, foi associado a um caso de pancreatite aguda, caracterizada como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. Essa reação é considerada clinicamente significativa e grave, pois o paciente não apresentou recuperação ou resolução até o momento, indicando que o quadro permanece em andamento. A suspeita de relação causal entre o uso do medicamento e o evento adverso reforça a necessidade de acompanhamento médico rigoroso e possível suspensão do fármaco, conforme avaliação clínica individualizada.

O medicamento Aspirin, com princípio ativo ácido acetilsalicílico, está relacionado a um episódio de pancreatite aguda, interpretado como uma reação de hipersensibilidade ao medicamento. O evento foi classificado como clinicamente significativo e grave, já que o paciente não se recuperou ou resolveu o quadro até o momento, permanecendo em evolução. A suspeita de vínculo entre o uso do ácido acetilsalicílico e a reação adversa exige atenção médica imediata para monitoramento e definição da conduta terapêutica adequada.

O medicamento Amitriptyline hydrochloride, cujo princípio ativo é a amitriptilina hidrocloridrato, foi associado a um caso de pancreatite aguda, considerada uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. O evento é classificado como clinicamente significativo e grave, pois o paciente segue sem recuperação ou resolução do quadro, indicando evolução persistente. A relação suspeita entre o uso do medicamento e a reação adversa demanda avaliação médica criteriosa para manejo e possível interrupção do tratamento.

O medicamento Simvastatin, com princípio ativo sinvastatina, foi relacionado a um caso de pancreatite aguda, interpretada como uma reação de hipersensibilidade ao medicamento. O evento é considerado clinicamente significativo e grave, já que o paciente não apresentou recuperação ou resolução até o momento, permanecendo em acompanhamento. A suspeita de ligação entre o uso da sinvastatina e a reação adversa reforça a importância de avaliação médica imediata para ajuste do tratamento e monitoramento do quadro clínico.

O medicamento Lavitan calcio + d, contendo os princípios ativos carbonato de cálcio e colecalciferol, foi associado a um episódio de pancreatite aguda, caracterizado como reação de hipersensibilidade medicamentosa. O evento foi classificado como clinicamente significativo e grave, pois o paciente não se recuperou ou resolveu o quadro até o momento, indicando evolução em andamento. A suspeita de relação causal entre o uso do suplemento e a reação adversa exige acompanhamento médico próximo para definição da conduta e monitoramento da evolução clínica.

O medicamento carbonato de cálcio, conhecido comercialmente como Os-cal, Calcitran e Cálcio 600, foi associado ao desenvolvimento de pancreatite aguda, que se manifesta por dor abdominal intensa e súbita, podendo vir acompanhada de náuseas e vômitos. Trata-se de uma reação adversa considerada clinicamente significativa, pois a pancreatite pode evoluir com complicações graves e requer acompanhamento médico rigoroso. Este evento é classificado como um distúrbio do sistema imunitário, ou seja, uma resposta alérgica do organismo ao medicamento. Até o momento, o quadro permanece em andamento, sem resolução completa, o que reforça a necessidade de suspensão imediata do uso do medicamento e busca de avaliação médica especializada. Siga rigorosamente as orientações do seu médico e fique atento a sinais de alerta como dor abdominal persistente, vômitos frequentes, febre ou piora do estado geral, procurando atendimento de urgência caso esses sintomas se intensifiquem.



O medicamento losartana, conhecido comercialmente como Cozaar, Aradois e Losartana Potássica, foi associado ao desenvolvimento de pancreatite aguda, que se manifesta por dor abdominal intensa e súbita, podendo vir acompanhada de náuseas e vômitos. Trata-se de uma reação adversa considerada clinicamente significativa, pois a inflamação do pâncreas pode evoluir com complicações graves e requer acompanhamento médico rigoroso. Este evento é classificado como um quadro alérgico relacionado ao sistema imunológico, já que envolve uma resposta do organismo ao medicamento. Até o momento, o quadro permanece em andamento, sem resolução completa, o que reforça a importância de suspender imediatamente o uso do losartana e buscar avaliação médica especializada. Siga rigorosamente as orientações do seu médico e fique atento a sinais de alerta como dor abdominal persistente, vômitos frequentes, febre ou piora do estado geral, procurando atendimento de urgência caso esses sintomas se intensifiquem.

O medicamento cálcio, cujo princípio ativo é cálcium e que pode ser encontrado em marcas como Cálcio EMS, Cálcio Sandoz e Cálcio Neo Química, foi associado ao desenvolvimento de pancreatite aguda, que se manifesta por dor abdominal intensa e súbita, podendo ser acompanhada de náuseas e vômitos. Trata-se de uma reação adversa considerada clinicamente significativa, pois envolve inflamação aguda do pâncreas, um quadro que pode evoluir com complicações graves e exige atenção médica imediata. Este evento é classificado como um distúrbio do sistema imunitário, ou seja, uma resposta alérgica ou de hipersensibilidade do organismo ao medicamento. Até o momento, o paciente não apresentou recuperação, permanecendo com sintomas em andamento, o que reforça a necessidade de acompanhamento rigoroso conforme as recomendações de segurança da ASBAI. Recomenda-se suspender imediatamente o uso do cálcio e procurar atendimento médico urgente ao primeiro sinal de dor abdominal forte, vômitos persistentes, febre ou mal-estar intenso, pois esses sintomas podem indicar agravamento do quadro. Mantenha-se atento a qualquer piora e nunca retome o uso do medicamento sem orientação especializada.

O medicamento acitretina, conhecido comercialmente como Neotigason, Soriatane e Acitretin Eurofarma, foi associado ao desenvolvimento de pancreatite aguda, que se manifesta por dor abdominal intensa e súbita, podendo ser acompanhada de náuseas e vômitos. Trata-se de uma reação adversa considerada clinicamente significativa, pois a pancreatite pode evoluir com complicações graves e requer atenção médica imediata. Este evento é classificado como um quadro alérgico relacionado a distúrbios do sistema imunitário, ou seja, uma resposta inadequada do organismo ao medicamento. Até o momento, o quadro permanece em andamento, sem resolução completa, o que reforça a necessidade de acompanhamento rigoroso. Recomenda-se suspender o uso do acitretin imediatamente e procurar atendimento médico de urgência, seguindo as orientações de segurança da ASBAI. Fique atento a sinais de alerta como dor abdominal persistente, vômitos, febre ou piora do estado geral, pois podem indicar agravamento do quadro e exigem avaliação médica rápida.

O medicamento anastrozol, conhecido comercialmente como Arimidex, Anastrozol Eurofarma e Anastrozol Sandoz, foi associado ao desenvolvimento de pancreatite aguda, que se manifesta por dor abdominal intensa e súbita, podendo vir acompanhada de náuseas e vômitos. Trata-se de uma reação adversa considerada clinicamente significativa, pois a inflamação aguda do pâncreas pode evoluir com complicações graves e exige atenção médica imediata. Este evento é classificado como um quadro alérgico relacionado a distúrbios do sistema imunitário, ou seja, uma resposta inadequada do organismo ao medicamento. Até o momento, o quadro permanece sem resolução, reforçando a necessidade de acompanhamento rigoroso conforme as recomendações de segurança da ASBAI. Recomenda-se suspender o uso do anastrozol e procurar atendimento médico urgente diante de sintomas como dor abdominal intensa, vômitos persistentes, febre ou pele amarelada, pois esses sinais podem indicar agravamento do quadro. O monitoramento contínuo e a comunicação imediata de qualquer novo sintoma ao médico são fundamentais para garantir a segurança do paciente.

O medicamento Cosentyx, cujo princípio ativo é o secuquinumabe, foi associado a um caso de pancreatite aguda, uma reação de hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos) classificada como clinicamente significativa e grave, conforme evidenciado pela gravidade relatada e pelo fato de o paciente não ter se recuperado até o momento. A conduta recomendada em situações de reações graves inclui a suspensão imediata do medicamento e acompanhamento médico especializado para manejo da complicação, sendo fundamental o monitoramento contínuo devido ao risco potencial à saúde.

O medicamento Paracetamol codeine, que contém codeína fosfato e paracetamol, foi relacionado a um episódio de desmaio, interpretado como uma reação de hipersensibilidade (alergia) de gravidade não classificada como grave, com o paciente em processo de recuperação. Em casos de reações leves a moderadas, recomenda-se observar a evolução dos sintomas, evitar nova exposição ao medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas terapêuticas.

O medicamento Histamine, cujo princípio ativo é a própria histamina, foi associado a um episódio de desmaio, considerado uma manifestação de hipersensibilidade (alergia) não grave, com o paciente em recuperação. Para reações leves, a conduta inclui monitoramento dos sintomas e avaliação médica para esclarecer a relação causal e orientar sobre futuras exposições, especialmente em contextos de testes alérgicos.

O medicamento Levothyroxine sodium, com princípio ativo levotiroxina sódica, foi relacionado a um episódio de desmaio, caracterizado como reação de hipersensibilidade (alergia) não grave, com evolução favorável e paciente em recuperação. Nessas situações, é importante avaliar a necessidade de ajuste ou troca do medicamento sob supervisão médica, além de monitorar possíveis recorrências.

O medicamento Clonazepam, cujo princípio ativo é o clonazepam, foi associado a um episódio de desmaio, interpretado como reação de hipersensibilidade (alergia) não grave, com o paciente em processo de recuperação. A recomendação é evitar o uso do medicamento suspeito até avaliação médica, que poderá confirmar a relação causal e indicar alternativas seguras para o tratamento.

O medicamento Prevoc, cujo princípio ativo é o cloridrato de ticlopidina, foi associado a um episódio de desmaio relacionado à hipersensibilidade (alergia), classificado como um quadro clínico alérgico do sistema imune. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso não foi considerado grave e o paciente encontra-se em recuperação. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico para monitorar a evolução e evitar nova exposição ao medicamento, visto que reações alérgicas podem se repetir.

O medicamento Propranolol hydrochloride, com o mesmo princípio ativo, esteve relacionado a um episódio de desmaio atribuído à hipersensibilidade (alergia), caracterizando um quadro alérgico do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade importante, já que o caso não foi considerado grave e o paciente está em recuperação. Recomenda-se acompanhamento médico e evitar reexposição ao propranolol, pois reações alérgicas podem se repetir.

O medicamento Clindamicin, cujo princípio ativo é o cloridrato de clindamicina, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como reação alérgica do sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade aumentada e o paciente já se encontra recuperado, indicando resolução completa do evento. A conduta é evitar nova exposição ao medicamento e manter acompanhamento clínico se necessário.

O medicamento Succinato de metoprolol, com princípio ativo metoprolol succinate, foi relacionado a um episódio de arritmia em paciente com alergia a iodo, sendo classificado como reação alérgica a medicamentos e outras substâncias químicas. Não há evidências de gravidade aumentada e o desfecho do caso é desconhecido, portanto recomenda-se acompanhamento médico para avaliação da relação entre o medicamento e o evento, além de evitar reexposição até esclarecimento completo.

O medicamento Ezetimibe, com princípio ativo ezetimibe, foi associado a um episódio de arritmia em paciente com alergia a iodo, sendo considerado uma reação alérgica a medicamentos e outras substâncias químicas. Não há sinais de gravidade importante e o desfecho permanece desconhecido, sendo indicado acompanhamento médico para investigação da relação causal e evitar nova exposição ao medicamento até esclarecimento do quadro.

O medicamento Novanlo, cujo princípio ativo é o levamlodipina besilato, foi associado a um episódio de arritmia em um paciente com histórico de alergia a iodo. A reação foi classificada como relacionada a distúrbios do sistema

imunitário, especificamente dentro do contexto de alergias a medicamentos e outras substâncias químicas. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a suspeita de relação com o medicamento foi registrada, mas sem evidências clínicas de gravidade importante, sugerindo que a reação não foi considerada grave.

A Aspirina Prevent, que contém ácido acetilsalicílico como princípio ativo, foi relacionada a um caso de arritmia em paciente com alergia a iodo. O evento foi enquadrado como distúrbio do sistema imunitário, mais especificamente uma alergia a medicamentos e substâncias químicas. Não há informações sobre gravidade significativa ou desfecho, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sem evidências clínicas de gravidade relevante.

O medicamento Rosucor, cujo princípio ativo é o cálcio de rosuvastatina, foi associado a um episódio de arritmia em paciente com alergia a iodo. A reação foi categorizada como distúrbio do sistema imunitário, dentro do grupo de alergias a medicamentos e outras substâncias químicas. Não há relato de gravidade importante nem desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é apenas suspeita, sem evidências clínicas de gravidade.

O medicamento Benicar HCT, que contém hidroclorotiazida e olmesartana medoxomila, foi relacionado a um caso de arritmia em paciente com alergia a iodo. O evento foi classificado como distúrbio do sistema imunitário, especificamente uma alergia a medicamentos e outras substâncias químicas. Não há indicação de gravidade relevante ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sem evidências clínicas de gravidade.

O medicamento Actemra, cujo princípio ativo é tocilizumabe, foi associado a um episódio de arritmia em paciente com alergia a iodo. A reação foi enquadrada como distúrbio do sistema imunitário, dentro do contexto de alergias a medicamentos e outras substâncias químicas. Não há relato de gravidade importante nem desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é apenas suspeita, sem evidências clínicas de gravidade.

O medicamento Revolade (eltrombopag olamina) foi associado a um quadro de hipersensibilidade durante transfusão, caracterizado como uma reação alérgica relevante do sistema imunitário. A gravidade foi considerada clinicamente significativa, pois o evento foi classificado como grave, embora o desfecho não tenha sido informado. Em situações como essa, é fundamental interromper a exposição ao medicamento suspeito e buscar avaliação médica imediata para manejo adequado da reação alérgica.

O medicamento Ancoron (amiodarona) apresentou um episódio de hipersensibilidade durante transfusão, indicando uma reação alérgica do sistema imunitário. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, o que exige atenção médica imediata, mesmo que o desfecho não tenha sido informado. Nessas situações, a conduta recomendada é suspender o uso do medicamento suspeito e realizar avaliação clínica para tratamento da reação alérgica.

O medicamento Soliris (eculizumabe) foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade durante transfusão, configurando uma reação alérgica do sistema imunitário. O evento foi classificado como clinicamente significativo e grave, o que reforça a necessidade de intervenção médica imediata, apesar do desfecho não ter sido informado. A recomendação é interromper o uso do medicamento suspeito e proceder com avaliação médica para manejo da reação.

O medicamento Soliris (eculizumabe) esteve envolvido em outro caso de hipersensibilidade durante transfusão, também caracterizado como reação alérgica do sistema imunitário. O evento foi considerado grave e clinicamente relevante, exigindo suspensão do medicamento e avaliação médica urgente, mesmo sem informação sobre o desfecho. O manejo deve priorizar a segurança do paciente e o controle da reação alérgica.

O medicamento Bromoprida (bromoprida) foi associado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica ao medicamento. O caso foi relacionado ao sistema imunitário e, segundo o registro, o paciente se recuperou totalmente após a reação. Nesses casos, é importante evitar nova exposição ao medicamento e informar o profissional de saúde sobre o histórico de alergia para prevenir recorrências.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o Iopromide, foi associado a um quadro de alergia a contraste, caracterizado como uma reação alérgica relevante do sistema imunológico. A gravidade foi considerada clinicamente significativa, pois o evento foi classificado como grave, mas o paciente evoluiu para recuperação completa. Em situações como essa, é fundamental reconhecer rapidamente os sintomas de alergia a contraste e adotar medidas de suporte, além de evitar futuras exposições ao mesmo agente.

O medicamento Entyvio, que contém Vedolizumab, esteve relacionado a um caso de estenose retal, interpretada como uma possível hipersensibilidade medicamentosa. Não há indicação de gravidade elevada nem detalhes sobre o desfecho, sugerindo que o evento não foi considerado grave. Em casos suspeitos de hipersensibilidade, é importante monitorar o paciente e avaliar a necessidade de ajuste ou suspensão do tratamento, conforme orientação médica.

O medicamento Humira ac, cujo princípio ativo é Adalimumabe, foi associado a um episódio de estenose retal, classificado como hipersensibilidade medicamentosa. Não há evidências de gravidade significativa nem informações sobre o desfecho, indicando que o evento não foi considerado grave. Nessas situações, recomenda-se acompanhamento clínico para avaliar a relação com o medicamento e decidir sobre a continuidade do uso.

A vacina COVID-19 AstraZeneca, com princípio ativo COVID-19 vaccine NRVV Ad (ChAdOx1 nCoV-19), esteve envolvida em um caso de alergia (hipersensibilidade), considerado clinicamente significativo e classificado como grave. Não há informações sobre o desfecho do caso. Reações alérgicas graves a vacinas exigem atenção imediata, com monitoramento e tratamento adequado, além de avaliação sobre a segurança de futuras doses.

A vacina COVID-19 AstraZeneca, cujo princípio ativo é COVID-19 vaccine NRVV Ad (ChAdOx1 nCoV-19), foi relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), também considerado clinicamente significativo e grave. Não há detalhes sobre a evolução do caso. Em situações de alergia grave após vacinação, é fundamental buscar atendimento médico imediato e discutir com o especialista sobre riscos e benefícios de novas aplicações.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, foi associado a um quadro de hipersensibilidade, descrito como alergia sem outros especificadores (SOE), relacionado a distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente. A reação foi considerada suspeita para o medicamento, e a conduta adequada é o acompanhamento clínico, com atenção a possíveis recorrências, mas sem necessidade de intervenções emergenciais.

O medicamento Avamis, que contém o princípio ativo fluticasona furoato, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade manifestado como imunodeficiência, dentro do contexto de distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade importante, já que o evento não foi classificado como grave e o desfecho permanece desconhecido. A reação foi considerada suspeita para o medicamento, sendo recomendada a avaliação clínica para monitoramento, sem necessidade de medidas urgentes até o momento.

O medicamento Flixotide, cujo princípio ativo é o propionato de fluticasona, foi associado a um episódio de hipersensibilidade manifestado como imunodeficiência, enquadrado em distúrbios do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade relevante, pois o evento não foi considerado grave e o desfecho é desconhecido. A relação com o medicamento é suspeita, sendo indicada a observação clínica e acompanhamento para esclarecimento do quadro.

O medicamento Seretide, composto por propionato de fluticasona e salmeterol xinafoato, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade apresentado como imunodeficiência, dentro da categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indícios de gravidade significativa, já que o evento não foi classificado como grave e o desfecho permanece desconhecido. A reação foi considerada suspeita para o medicamento, recomendando-se acompanhamento clínico para avaliação da evolução.

O medicamento Aradois, cujo princípio ativo é o losartana potássica, foi associado a um quadro de hipersensibilidade manifestado como imunodeficiência, relacionado a distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade, pois o evento não foi considerado grave e o desfecho é desconhecido. A relação com o medicamento é suspeita, sendo indicada a observação clínica e acompanhamento para monitoramento do quadro.

O medicamento Verapamil, cujo princípio ativo também é verapamil, foi associado a um quadro de imunodeficiência descrito como hipersensibilidade, dentro do contexto de reações alérgicas do sistema imune. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A reação sugere uma alteração imunológica, mas sem sinais de gravidade clínica importante relatados, sendo fundamental acompanhamento médico para avaliação e conduta adequada.

O Xolair, que tem como princípio ativo o omalizumabe, foi relacionado a um episódio de imunodeficiência classificado como hipersensibilidade, caracterizando uma possível reação alérgica do sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade significativa ou desfecho, e a relação com o medicamento é suspeita. A manifestação sugere alteração imunológica, mas sem evidências de gravidade, sendo recomendada avaliação médica para monitoramento.

O medicamento Benzetacil, cujo princípio ativo é a benzilpenicilina benzatina, foi prescrito apesar de haver hipersensibilidade documentada ao produto, o que caracteriza um erro de prescrição e representa risco potencial de reação alérgica grave. Não há detalhes sobre gravidade, desfecho ou ação adotada, mas a conduta correta seria evitar o uso do medicamento e buscar alternativas seguras, além de acompanhamento especializado para prevenção de complicações.

O Profenid, que contém cetoprofeno como princípio ativo, foi associado a um episódio de desmaio em paciente com histórico de alergias múltiplas, indicando uma possível reação alérgica do sistema imunológico. Não há relato de gravidade importante ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é suspeita. A situação sugere necessidade de avaliação médica para investigação da causa do desmaio e orientação sobre o uso futuro de anti-inflamatórios.

A Dipirona, cujo princípio ativo é o metamizol sódico, foi relacionada a um episódio de desmaio em paciente com alergias múltiplas, sugerindo uma possível reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é suspeita. Recomenda-se avaliação médica para esclarecimento da reação e definição de alternativas seguras para controle da dor ou febre.

O medicamento Decadron, cujo princípio ativo é a dexametasona tebutato, foi associado a um episódio de desmaio em um paciente com histórico de alergias múltiplas. Embora o registro não indique gravidade elevada ou necessidade de hospitalização, o desmaio pode ser um sinal de reação adversa relacionada ao sistema imunológico, sendo importante observar o paciente e buscar avaliação médica para descartar causas graves e orientar conduta adequada.

O medicamento Saline, que contém cloreto de sódio como princípio ativo, foi relacionado a um episódio de desmaio em um paciente com alergias múltiplas. Apesar de não haver indicação de gravidade significativa ou hospitalização, o desmaio deve ser monitorado, pois pode indicar uma reação adversa do sistema imunológico, e recomenda-se avaliação médica para investigação e orientação.

O Xolair, cujo princípio ativo é o omalizumabe, foi associado a um episódio de desmaio em paciente com histórico de alergias múltiplas. Não há evidência de gravidade importante ou necessidade de hospitalização, mas o desmaio pode estar relacionado a uma reação alérgica, sendo fundamental monitorar o paciente e buscar avaliação médica para esclarecimento e conduta adequada.

O medicamento Endofolin, que contém ácido fólico como princípio ativo, provocou uma reação alérgica (hipersensibilidade) que resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, indicando gravidade

significativa. O paciente se recuperou totalmente após a reação, e a conduta adequada inclui evitar nova exposição ao medicamento e acompanhamento com especialista para prevenção de recorrências.

O Metotrexato, cujo princípio ativo é o metotrexato, causou uma reação alérgica (hipersensibilidade) que levou à hospitalização ou prolongamento da internação, caracterizando um evento grave. O paciente se recuperou após a reação, sendo fundamental evitar o uso futuro do medicamento e realizar acompanhamento médico para manejo seguro de possíveis alergias medicamentosas.

O medicamento Cimzia, cujo princípio ativo é o certolizumabe pegol, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando a necessidade de atenção médica imediata. Após a conduta adequada, o paciente se recuperou totalmente do episódio.

O medicamento Xolair, com princípio ativo omalizumabe, esteve relacionado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), descrito como dependência de droga ou medicamento, dentro da categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade clínica relevante neste caso, e o desfecho permanece em andamento, sem resolução completa até o momento.

O produto Vitamin C, cujo princípio ativo é cálcium ascorbate, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia) com manifestação de fratura do fêmur, classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade significativa, e o paciente se recuperou totalmente após o evento.

O medicamento Galexan, com princípio ativo gallamine triethiodide, esteve associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia) manifestado por fratura do fêmur, enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa.

O medicamento Digeplus, composto por dimeticona, cloridrato de metoclopramida e pepsina, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia) com manifestação de fratura do fêmur, classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não houve gravidade relevante e o paciente se recuperou totalmente após o evento.

O medicamento Indapen, cujo princípio ativo é a indapamida, foi associado a um episódio de fratura do fêmur em um contexto de hipersensibilidade (reação alérgica), classificada como um quadro clínico alérgico relacionado a distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A relação entre o medicamento e a reação foi considerada suspeita, e a conduta adotada resultou em resolução completa do quadro.

O medicamento Omeprazole, com princípio ativo omeprazol, esteve envolvido em um caso de fratura do fêmur associado a hipersensibilidade, caracterizando um quadro alérgico do sistema imune. O evento não foi considerado grave, e o paciente evoluiu para recuperação completa. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, e não houve complicações adicionais relatadas.

O medicamento Puran t4, cujo princípio ativo é levotiroxina sódica, foi relacionado a um episódio de fratura do fêmur em um contexto de hipersensibilidade, enquadrando-se como um quadro alérgico do sistema imunológico. O evento não foi classificado como grave e o paciente se recuperou totalmente, sendo a relação com o medicamento considerada suspeita.

O medicamento Exodos, que contém pseudoefedrina hidrocloreídrica e triprolidina hidrocloreídrica como princípios ativos, foi associado a uma fratura do fêmur em um contexto de hipersensibilidade, caracterizando um quadro alérgico do sistema imune. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente, com suspeita de relação entre o medicamento e a reação.

O medicamento Mekinist, cujo princípio ativo é trametinibe dimetilsulfóxido, esteve envolvido em um episódio de fratura do fêmur associado a hipersensibilidade, sendo este um quadro alérgico do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, havendo suspeita de relação causal com o medicamento.

O medicamento Tafinlar, cujo princípio ativo é o dabrafenibe mesilato, foi associado a um quadro de fratura do fêmur em um paciente com histórico de hipersensibilidade (alergia), classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Apesar de não haver indicação de gravidade clínica relevante neste caso e o paciente ter se recuperado, é importante monitorar possíveis reações alérgicas durante o uso, mesmo que o evento tenha sido resolvido.

O medicamento Zinnat, que contém cefuroxima axetil, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), considerado clinicamente significativo e classificado como grave devido ao potencial impacto no sistema imunitário. O desfecho do caso é desconhecido, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico imediato diante de sinais de alergia a antibióticos, pois reações graves podem evoluir rapidamente.

O medicamento Trileptal, cujo princípio ativo é a oxcarbazepina, foi associado a um quadro de paralisia relacionado à hipersensibilidade (alergia), enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade relevante neste caso e o desfecho permanece desconhecido, sendo fundamental relatar qualquer sintoma neurológico ou alérgico ao médico para avaliação adequada.

O medicamento Euthyrox, que contém levotiroxina sódica, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade) que resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, caracterizando um evento grave do ponto de vista clínico. O paciente não se recuperou até o momento, o que exige acompanhamento médico rigoroso e possível ajuste terapêutico para evitar complicações.

O medicamento Dexamethasone, cujo princípio ativo é a dexametasona, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade) que levou à hospitalização ou prolongamento da internação, sendo considerado um evento grave. O paciente ainda não se recuperou, o que reforça a importância de monitoramento médico contínuo e avaliação criteriosa do uso de corticoides em pessoas com histórico de reações alérgicas.

O medicamento Donaren, cujo princípio ativo é o cloridrato de trazodona, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, manifestando-se como uma reação alérgica do sistema imunológico. A gravidade do caso é evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando um evento adverso importante que exige acompanhamento médico rigoroso. Até o momento, o desfecho permanece não resolvido, com o paciente ainda em evolução clínica, sendo fundamental o monitoramento contínuo e a avaliação de condutas específicas para controle da reação.

O medicamento Hydantal, contendo mefenitoína e fenobarbital como princípios ativos, desencadeou uma reação de alergia classificada como hipersensibilidade, refletindo uma resposta imunológica adversa. O caso foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que reforça a importância de intervenção médica imediata. O paciente ainda não apresentou resolução do quadro, permanecendo em acompanhamento, o que destaca a necessidade de vigilância clínica e possível ajuste terapêutico.

O Crestor, cujo princípio ativo é o cálcio de rosuvastatina, foi relacionado a um episódio de alergia do tipo hipersensibilidade, envolvendo o sistema imunológico. A gravidade do evento é confirmada pela hospitalização ou prolongamento da internação, sugerindo uma reação adversa significativa que demanda atenção médica especializada. O quadro permanece em andamento, sem recuperação até o momento, sendo essencial o acompanhamento contínuo para manejo adequado da reação.

O medicamento Mekinist, com princípio ativo trametinibe dimetil sulfóxido, esteve associado a uma reação alérgica classificada como hipersensibilidade, indicando envolvimento do sistema imunológico. O caso foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou necessidade de prolongar a internação, o que evidencia a importância de monitoramento médico intensivo. O desfecho ainda não foi alcançado, com o paciente em evolução clínica, ressaltando a necessidade de acompanhamento próximo e avaliação de estratégias terapêuticas.

O Tafenlar, cujo princípio ativo é o mesilato de dabrafenibe, foi implicado em um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, refletindo uma resposta adversa do sistema imunológico. A gravidade do evento é demonstrada pela hospitalização ou prolongamento da internação, indicando um risco clínico relevante que requer supervisão médica constante. O paciente ainda não se recuperou, permanecendo em acompanhamento, o que reforça a importância de vigilância e possível revisão do tratamento.

O medicamento Stilnox, cujo princípio ativo é o zolpidem tartrate, foi associado a um quadro de agravamento da esclerose múltipla, descrito como uma reação de hipersensibilidade (alergia). Embora o registro não indique sintomas graves ou desfecho conhecido, a reação foi classificada como não grave e não há informações sobre a necessidade de intervenção médica imediata. A relação suspeita entre o uso do medicamento e o evento sugere a importância de monitoramento clínico, especialmente em pacientes com histórico de doenças autoimunes, mas não há evidências de complicações graves neste caso.

O canabidiol (princípio ativo cannabidiol) foi relacionado a um agravamento da esclerose múltipla, caracterizado como uma reação de hipersensibilidade (alergia). Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho definido, e a reação foi considerada não grave. A suspeita de relação entre o uso do canabidiol e o evento reforça a necessidade de acompanhamento médico, principalmente em pacientes com doenças autoimunes, mas não há sinais de evolução crítica ou necessidade de intervenção urgente neste relato.

O medicamento Copaxone teva, que contém o princípio ativo glatiramer acetate, foi associado ao agravamento da esclerose múltipla, descrito como uma reação de hipersensibilidade (alergia). O evento não foi considerado grave e o desfecho permanece desconhecido, sem informações sobre complicações adicionais ou necessidade de medidas emergenciais. A relação suspeita entre o uso do medicamento e o agravamento do quadro sugere a importância de acompanhamento clínico, mas não há evidências de gravidade significativa neste caso.

O medicamento Ringer, composto por calcium chloride dihydrate, magnesium chloride, potassium chloride e sodium acetate, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), sem detalhamento de sintomas graves. O evento foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando que a reação foi autolimitada e não exigiu intervenções complexas. A suspeita de relação com o medicamento reforça a necessidade de atenção a possíveis reações alérgicas, mas o desfecho favorável sugere que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro.

O medicamento Hytamicina, cujo princípio ativo é o gentamicin sulfate, foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), sem relato de sintomas graves. O caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou completamente, indicando que a reação foi leve e autolimitada. A relação suspeita com o uso do medicamento destaca a importância de monitoramento para reações alérgicas, mas o desfecho positivo sugere que não houve necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Gentamicin, cujo princípio ativo é o sulfato de gentamicina, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente, e não foram relatados sintomas graves ou complicações. A conduta recomendada em casos de hipersensibilidade leve é interromper o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas terapêuticas.

A vacina COVID-19 (recombinante), com princípio ativo ChAdOx1 nCoV-19, foi relacionada a uma alteração da cor da pele, interpretada como manifestação de hipersensibilidade (alergia). Não há informações sobre sintomas



graves ou evolução clínica, e o desfecho é desconhecido. Em situações de reações leves de pele após vacinação, recomenda-se observar a evolução dos sintomas e procurar avaliação médica caso haja piora ou persistência, sempre informando o histórico vacinal ao profissional de saúde.

O medicamento Simvastatin - 1 A Pharma, contendo simvastatina, foi associado ao surgimento de inchaço, caracterizando uma reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico. Não há relato de gravidade importante nem de complicações, e o desfecho permanece desconhecido. Em casos de inchaço leve relacionado a medicamentos, recomenda-se suspender o uso e buscar avaliação médica para investigação e definição do tratamento mais seguro.

O medicamento Carvedilol, com princípio ativo carvedilol, foi relacionado ao aparecimento de inchaço, indicando uma reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade significativa ou evolução desfavorável, e o desfecho não foi informado. Diante de inchaço leve após uso de carvedilol, é indicado interromper o medicamento e procurar orientação médica para avaliação e conduta adequada.

O medicamento Losartan, cujo princípio ativo é losartana, foi associado ao desenvolvimento de inchaço, caracterizando uma reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade ou complicações relatadas, e o desfecho é desconhecido. Em situações de inchaço leve após uso de losartana, recomenda-se suspender o medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e ajuste do tratamento.

O medicamento Xolair, cujo princípio ativo é o Omalizumabe, foi associado a um quadro de inchaço, caracterizado como reação de hipersensibilidade (alergia), pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho definido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Recomenda-se atenção clínica para monitoramento de sintomas alérgicos, com avaliação médica para confirmação e orientação sobre controle ambiental e identificação de possíveis gatilhos, conforme diretrizes da ASBAI.

O medicamento Desogestrel, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado ao aparecimento de sangue nas fezes em um contexto de alergia alimentar, sugerindo possível alergia ao leite. Trata-se de uma reação imunológica, mas não há indicação de gravidade elevada, sendo o quadro ainda não resolvido. A conduta recomendada é investigação médica para confirmação diagnóstica, evitando exposição ao possível alérgeno e acompanhamento especializado para manejo adequado, conforme orientação da ASBAI.

O medicamento Rocefin, cujo princípio ativo é o ceftriaxona sódica, foi associado a um episódio de alergia, caracterizado como hipersensibilidade, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhes sobre gravidade, desfecho ou evolução do caso, mas a relação com o medicamento é considerada suspeita. Recomenda-se avaliação médica para confirmação da alergia e definição de conduta, incluindo possível encaminhamento ao especialista para investigação e prevenção de novas exposições.

A vacina COVID-19 AstraZeneca, com princípio ativo ChAdOx1 nCoV-19, foi associada a um quadro de alergia (hipersensibilidade) classificado como clinicamente significativo e grave, ainda não resolvido. Diante da gravidade relatada, é fundamental acompanhamento médico rigoroso, investigação detalhada da reação e, se necessário, encaminhamento ao especialista para manejo seguro e prevenção de complicações, conforme recomendações da ASBAI para quadros alérgicos graves.

O medicamento Dipirona, cujo princípio ativo é o metamizol sódico, foi prescrito apesar de haver hipersensibilidade documentada ao produto, configurando um erro de prescrição em paciente alérgico. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, mas a situação exige suspensão imediata do medicamento e avaliação médica para evitar reações adversas, reforçando a importância de sempre respeitar contraindicações por alergia, conforme orientações da ASBAI.

O medicamento Herzuma, cujo princípio ativo é o trastuzumabe, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo de reações alérgicas do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente. A conduta recomendada em situações de hipersensibilidade leve é observar o paciente, evitar nova exposição ao medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições.

O medicamento Docetaxel, com princípio ativo de mesmo nome, esteve relacionado a uma reação de alergia do tipo hipersensibilidade, enquadrada entre quadros clínicos alérgicos do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa. Em casos de hipersensibilidade leve, recomenda-se suspender o uso do medicamento suspeito, monitorar sintomas e procurar avaliação médica para confirmação e orientação sobre riscos em futuras administrações.

A Novalgina, cujo princípio ativo é o metamizol sódico, foi associada a um episódio de febre relacionado a hipersensibilidade, classificado como reação alérgica do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou. Em situações de hipersensibilidade leve, a recomendação é interromper o uso do medicamento suspeito, observar a evolução dos sintomas e buscar orientação médica para avaliação e prevenção de novas reações.

O medicamento Bromoprida, com princípio ativo bromoprida, foi relacionado a um caso de cirrose hepática descrito como alergia a substâncias químicas, dentro do grupo de distúrbios do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada e o desfecho do caso é desconhecido. Diante de suspeita de reação alérgica a medicamentos, especialmente com envolvimento hepático, recomenda-se suspender o uso do fármaco e encaminhar para avaliação médica especializada para investigação e manejo adequado.

O medicamento Dramin, cujo princípio ativo é o dimenidrinato, foi associado a um caso de cirrose hepática classificado como alergia a substâncias químicas, pertencente ao grupo de distúrbios do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o desfecho permanece desconhecido. Em situações de suspeita de reação alérgica medicamentosa com possível acometimento hepático, é indicado interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica para investigação detalhada e definição da conduta.

O medicamento Silimalon, que contém como princípios ativos DL-methionine e Silybum marianum, foi associado a um caso de cirrose hepática, uma condição grave do fígado, sendo classificada como uma possível reação alérgica a substâncias químicas. Não há informações detalhadas sobre a gravidade clínica, desfecho ou conduta adotada, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, o que indica a necessidade de acompanhamento médico para avaliação da causalidade e monitoramento do quadro.

O medicamento Roxflan, cujo princípio ativo é o Amlodipine besilate, foi relacionado a um caso de cirrose hepática, que é uma doença crônica do fígado, sendo interpretada como uma possível reação alérgica a substâncias químicas. Não há detalhes sobre a gravidade, evolução do caso ou medidas tomadas, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, recomendando-se avaliação médica para investigação da causa e acompanhamento do paciente.

O medicamento Pantoprazole, com princípio ativo de mesmo nome, foi associado a um episódio de cirrose hepática, uma condição séria do fígado, sendo classificada como possível alergia a substâncias químicas. Não há informações sobre a gravidade, desfecho ou conduta adotada, e a relação com o medicamento é suspeita, o que reforça a importância de avaliação clínica detalhada para esclarecimento do quadro.

O medicamento Inzelm, cujo princípio ativo é o Vonoprazan fumarate, foi relacionado a um caso de cirrose hepática, uma doença crônica do fígado, interpretada como possível reação alérgica a substâncias químicas. Não há dados sobre a gravidade, evolução ou conduta, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo fundamental acompanhamento médico para investigação e manejo adequado.

O medicamento Ampicilina sódica + sulbactam sódico, contendo os princípios ativos Ampicillin sodium e Sulbactam sodium, foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), que se enquadra em quadros clínicos alérgicos do sistema imunológico. Não há informações sobre a gravidade, desfecho ou conduta adotada, mas a relação com o medicamento é suspeita, indicando a necessidade de avaliação médica para confirmação do diagnóstico e definição do tratamento.

O medicamento Ampicilina sódica + sulbactam sódica (princípios ativos: ampicillin sodium e sulbactam sodium) foi associado a um quadro de alergia, descrito como hipersensibilidade, que se enquadra nos distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhes sobre a gravidade, desfecho ou conduta adotada, mas reações alérgicas a antibióticos exigem atenção clínica para avaliação da necessidade de suspensão do medicamento e investigação de alternativas seguras.

O medicamento Profenid (princípio ativo: ketoprofen) foi relacionado a uma reação de alergia a medicamentos tópicos, caracterizada como hipersensibilidade medicamentosa, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. O caso evoluiu para recuperação completa, sugerindo que a conduta adotada foi eficaz, provavelmente com a suspensão do uso e medidas de suporte, conforme recomendado para quadros leves de alergia cutânea.

O medicamento Comirnaty (princípio ativo: tozinameran) foi utilizado em situação não descrita na bula (off label) e resultou em uma reação de alergia à vacina, classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há informação sobre gravidade ou desfecho, mas a ausência de gravidade relatada sugere que o evento não foi considerado grave, sendo importante monitorar e relatar qualquer sintoma alérgico após vacinação para avaliação médica adequada.

O medicamento Morfina (princípio ativo: morphine sulfate) foi associado a um episódio de alergia, descrito como hipersensibilidade, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. O desfecho foi de recuperação ou resolução do quadro, indicando que a reação foi controlada, provavelmente com a suspensão do medicamento e medidas de suporte, conduta alinhada ao manejo de reações alérgicas leves a moderadas.

O medicamento Escitalopram oxalate (princípio ativo: escitalopram oxalate) foi relacionado a um ataque cardíaco, descrito como hipersensibilidade medicamentosa, dentro da categoria de distúrbios do sistema imunitário. O evento foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação e teve outro efeito clinicamente significativo, sendo fundamental a suspensão imediata do medicamento e acompanhamento médico intensivo, embora o desfecho não tenha sido informado.

O medicamento Escitalopram oxalate (princípio ativo: Escitalopram oxalate) foi associado a um episódio de ataque cardíaco, considerado uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. Esse evento é classificado como grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e por ser clinicamente significativo, conforme registrado. O desfecho do caso é desconhecido e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo fundamental acompanhamento médico imediato e investigação detalhada para avaliar riscos e condutas.

O medicamento Risperidone (princípio ativo: Risperidone) foi relacionado a um ataque cardíaco, caracterizado como uma reação de hipersensibilidade ao medicamento. A gravidade do evento é evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e por ser clinicamente relevante. O desfecho permanece desconhecido e a relação com o uso do medicamento é suspeita, exigindo avaliação médica urgente e monitoramento rigoroso.

O medicamento Tysabri (princípio ativo: Natalizumab) foi associado a um ataque cardíaco, interpretado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. O caso é considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação e apresenta impacto clínico importante. O desfecho não foi informado e a relação com o medicamento é suspeita, sendo necessária atenção médica imediata e investigação da causa.

O medicamento Tysabri (princípio ativo: Natalizumab) está envolvido em um relato de ataque cardíaco, classificado como reação de hipersensibilidade ao medicamento. O evento é considerado grave devido à hospitalização ou prolongamento da internação e à relevância clínica do quadro. O desfecho é desconhecido e a relação com o medicamento é suspeita, recomendando-se avaliação médica urgente e acompanhamento próximo.

O medicamento Tysabri (princípio ativo: Natalizumab) foi relacionado a um ataque cardíaco, interpretado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. O evento é grave, pois levou à hospitalização ou prolongamento da internação e apresenta importância clínica significativa. O desfecho não foi informado e a relação com o medicamento é suspeita, sendo imprescindível investigação médica imediata e monitoramento do paciente.

O medicamento Hydroxychloroquine (princípio ativo: Hydroxychloroquine) foi associado a um distúrbio não especificado do intestino, interpretado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso evoluiu para recuperação completa, sem complicações graves relatadas. A conduta recomendada em situações semelhantes é suspender o uso do medicamento suspeito e monitorar a resolução dos sintomas, buscando avaliação médica para confirmação e orientação sobre alternativas terapêuticas.

O Methotrexate (princípio ativo: Methotrexate) foi relacionado a um distúrbio não especificado do intestino, caracterizando uma hipersensibilidade medicamentosa, que é uma reação alérgica do sistema imunológico ao fármaco. O caso não apresentou sinais de gravidade, já que houve recuperação total do paciente. Nessas situações, recomenda-se interromper o uso do medicamento suspeito e procurar orientação médica para avaliação e definição do tratamento mais seguro.

O medicamento Higroton, cujo princípio ativo é Chlortalidone, esteve associado a um distúrbio não especificado do intestino, interpretado como hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Não há evidências de gravidade, pois o paciente se recuperou completamente. A conduta adequada é suspender o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas.

O medicamento Calcium (princípio ativo: Calcium) foi relacionado a um distúrbio não especificado do intestino, caracterizando uma hipersensibilidade medicamentosa, que é uma reação alérgica do sistema imunológico ao medicamento. O caso não foi grave, pois houve recuperação total do paciente. Recomenda-se interromper o uso do medicamento suspeito e procurar avaliação médica para confirmação e definição do tratamento mais seguro.

O Propranolol (princípio ativo: Propranolol) foi associado a um distúrbio não especificado do intestino, interpretado como hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Não há sinais de gravidade, já que o paciente se recuperou totalmente. A conduta recomendada é suspender o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas terapêuticas.

O medicamento Chloroquine (princípio ativo: Chloroquine) foi associado a um distúrbio não especificado do intestino, interpretado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso evoluiu para recuperação completa, e não há menção de complicações graves ou necessidade de intervenção médica urgente. A conduta recomendada em situações semelhantes é a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento clínico para evitar novas exposições.

O medicamento Enbrel (princípio ativo: Etanercept) foi relacionado a um distúrbio não especificado do intestino, caracterizado como hipersensibilidade medicamentosa, o que sugere uma reação alérgica do sistema imunológico ao fármaco. O caso não foi considerado grave, pois houve resolução completa dos sintomas, sem relato de complicações importantes. Em situações como essa, recomenda-se interromper o uso do medicamento suspeito e

realizar acompanhamento médico para evitar recorrências.

O medicamento Eszopiclone (princípio ativo: Eszopiclone) foi associado a uma reação de hipersensibilidade, descrita tecnicamente como um quadro clínico alérgico, embora a reação relatada tenha sido 'cirurgia bariátrica', o que não é típico de reações alérgicas e pode indicar erro de classificação. Não há evidência de gravidade aumentada, mas o caso permanece em andamento, sem resolução até o momento. Recomenda-se acompanhamento médico para esclarecimento do quadro e monitoramento da evolução.

O medicamento Ansitec (princípio ativo: Buspirona hydrochloride) foi relacionado a uma reação de hipersensibilidade, classificada como quadro clínico alérgico, embora a reação relatada tenha sido 'cirurgia bariátrica', o que não corresponde a manifestações alérgicas típicas e pode indicar erro de registro. O caso não foi considerado grave, mas permanece sem resolução, sendo importante manter acompanhamento médico para avaliação e esclarecimento da situação.

O medicamento Puran t4 (princípio ativo: Levothyroxine sodium) foi associado a uma reação de hipersensibilidade, descrita como quadro clínico alérgico, porém a reação relatada foi 'cirurgia bariátrica', o que não é compatível com manifestações alérgicas e pode indicar erro de classificação. Não há sinais de gravidade aumentada, mas o caso segue em andamento, sem resolução, sendo recomendada avaliação médica para melhor definição do quadro e conduta adequada.

O medicamento Dupilumab, cujo princípio ativo também é Dupilumab, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há informação sobre gravidade clínica específica neste caso, mas o desfecho indica que o paciente ainda não se recuperou ou está em acompanhamento. A relação entre o medicamento e a reação é considerada suspeita, sendo importante manter acompanhamento médico para monitorar a evolução do quadro.

O medicamento Zovirax, com princípio ativo Aciclovir sodium, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), caracterizado como distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa após o evento. A relação entre o uso do medicamento e a reação é suspeita, e não há indicação de necessidade de condutas adicionais além do acompanhamento clínico habitual.

O medicamento Berotec, cujo princípio ativo é Fenoterol hydrobromide, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), com manifestação relacionada à exposição a poeira, classificado como distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado de ameaça à vida, evidenciado pela gravidade informada e pelo fato de o paciente ainda não ter se recuperado ou estar em acompanhamento. Diante da gravidade, é fundamental buscar avaliação médica urgente e monitoramento contínuo.

O medicamento Aerolin, com princípio ativo Salbutamol sulfate, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), também associado à exposição a poeira e classificado como distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado de ameaça à vida, pois o paciente não se recuperou ou permanece em acompanhamento, sendo necessária atenção médica imediata e acompanhamento rigoroso devido ao risco envolvido.

O medicamento Sinocort, cujo princípio ativo é Mometasone furoate, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia) relacionado à exposição a poeira, classificado como distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado de ameaça à vida, já que o paciente não se recuperou ou está em acompanhamento, exigindo avaliação médica urgente e monitoramento próximo para evitar complicações.

O medicamento Diamicon, cujo princípio ativo é a Gliclazida, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), manifestando-se como uma reação alérgica grave relacionada ao sistema imunológico. A gravidade é considerada ameaça à vida, conforme evidenciado pela classificação clínica e pelo fato de o paciente não ter se recuperado até o momento, estando o caso em andamento. Diante desse cenário, é fundamental interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica urgente para manejo adequado da reação alérgica, seguindo as

recomendações de farmacovigilância e alergologia.

O medicamento Azukon, também contendo Gliclazida como princípio ativo, apresentou relato de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica importante do sistema imunológico. A situação é considerada de ameaça à vida, pois o quadro permanece não resolvido e em andamento, exigindo atenção imediata. Recomenda-se suspensão do uso e procura de atendimento médico especializado para avaliação e tratamento da reação, conforme orientações clínicas para eventos adversos graves.

O medicamento Seretide, composto por propionato de fluticasona e xinafoato de salmeterol, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica relevante do sistema imunológico. O caso é classificado como ameaça à vida, já que o paciente não se recuperou e o evento permanece em andamento, indicando necessidade de intervenção médica urgente. É imprescindível interromper o uso do medicamento e buscar avaliação especializada para controle da reação alérgica grave.

A amoxicilina, cujo princípio ativo é a amoxicilina, foi associada a um quadro de hipersensibilidade, representando uma reação alérgica significativa do sistema imunológico. O evento é considerado de ameaça à vida, pois o paciente não apresentou recuperação e o quadro segue em andamento, o que exige suspensão imediata do medicamento e procura de atendimento médico de urgência para manejo adequado da reação alérgica.

O medicamento Puran T4, que contém levotiroxina sódica como princípio ativo, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico com gravidade de ameaça à vida. O paciente não se recuperou e o quadro permanece em andamento, sendo fundamental interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica urgente para tratamento da reação alérgica grave.

O medicamento Busonid, cujo princípio ativo é a budesonida, foi associado a um quadro de hipersensibilidade, que significa uma reação alérgica do sistema imunológico, neste caso relacionada à exposição a poeira. A gravidade foi classificada como ameaça à vida, evidenciada pela indicação de gravidade elevada e evolução ainda não resolvida, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico rigoroso e possível intervenção urgente para evitar complicações maiores.

O Polaramine, que contém como princípio ativo o maleato de dexclorfeniramina, apresentou reação de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta alérgica do organismo, também relacionada à poeira. O caso foi considerado de ameaça à vida, pois permanece sem resolução e com gravidade significativa, exigindo atenção médica imediata para controle dos sintomas e prevenção de riscos maiores ao paciente.

O medicamento Histamin, cujo princípio ativo é a histamina, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica importante ao contato com poeira. A situação foi classificada como ameaça à vida, com evolução ainda em andamento e sem recuperação, o que indica a necessidade de avaliação médica urgente para manejo adequado e redução do risco de complicações graves.

A prednisona, princípio ativo do medicamento Prednisona, foi associada a uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico à poeira. O quadro foi considerado de ameaça à vida, pois permanece não resolvido e com gravidade elevada, sendo fundamental acompanhamento médico imediato para evitar agravamento do estado clínico.

A Sinvastatina, cujo princípio ativo é a simvastatina, desencadeou uma reação de hipersensibilidade, que corresponde a uma resposta alérgica do organismo à poeira. O caso foi classificado como ameaça à vida, com evolução ainda não resolvida, o que exige atenção médica especializada para monitoramento e intervenção rápida, visando a segurança do paciente.

O medicamento Omeprazol, cujo princípio ativo é o omeprazole, foi associado a um quadro de hipersensibilidade, que pode ser entendido como uma reação alérgica, neste caso relacionada a sintomas semelhantes à alergia à

poeira. A reação foi classificada como uma ameaça à vida, evidenciada pela gravidade informada e pelo fato de o paciente não ter se recuperado até o momento, indicando a necessidade de acompanhamento médico rigoroso e possível intervenção especializada para controle da resposta imunológica.

O Glycopyrronium bromide, tanto como nome comercial quanto como princípio ativo, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, manifestando-se como sintomas típicos de alergia à poeira. A gravidade foi considerada ameaça à vida, pois o paciente permanece sem recuperação, o que reforça a importância de avaliação médica imediata e monitoramento contínuo para evitar complicações graves decorrentes da resposta alérgica.

O medicamento Seebri breezhaler, cujo princípio ativo é o glycopyrronium bromide, desencadeou uma reação de hipersensibilidade, caracterizada por sintomas semelhantes aos de alergia à poeira. O evento foi classificado como ameaça à vida, com o paciente ainda não recuperado, o que exige atenção médica urgente e acompanhamento especializado para manejo adequado da reação alérgica.

O Xolair, que tem como princípio ativo o omalizumab, foi associado a um quadro de hipersensibilidade, manifestando sintomas compatíveis com alergia à poeira. A reação foi considerada uma ameaça à vida, já que o paciente não apresentou recuperação até o momento, sendo fundamental a supervisão médica e possível ajuste do tratamento para evitar riscos maiores à saúde.

A vacina COVID-19 AstraZeneca, cujo princípio ativo é o COVID-19 vaccine NRVV Ad (ChAdOx1 nCoV-19), foi relacionada a um episódio de angioedema, que é um inchaço súbito de pele e mucosas decorrente de hipersensibilidade. Neste caso, a gravidade não foi considerada alta e o desfecho permanece desconhecido, sendo importante monitorar o paciente e buscar orientação médica caso haja piora dos sintomas.

O medicamento Cloreto de sódio (princípio ativo: Sodium chloride) foi associado a prurido, que é uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Não há indicação de gravidade significativa neste caso, e o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo uma reação leve e autolimitada.

O medicamento Amoxicilina clavulanato de potássio (princípios ativos: Amoxicillin sodium e Clavulanate potassium) provocou prurido, caracterizando uma hipersensibilidade medicamentosa, que é uma reação alérgica do sistema imunológico ao antibiótico. Não há sinais de gravidade relevante relatados, e o paciente se recuperou completamente, indicando uma reação leve e resolutive.

O medicamento Adriblastina (princípio ativo: Doxorubicin hydrochloride) causou um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como clinicamente significativo, o que indica uma reação de maior gravidade. Apesar disso, o paciente se recuperou após o evento, mas a gravidade foi destacada devido ao potencial impacto clínico da reação alérgica ao medicamento.

O medicamento Dipifarma (princípio ativo: Metamizole sodium) foi prescrito apesar de haver contraindicação documentada por hipersensibilidade ao produto, o que representa um erro de prescrição com risco potencial de reação alérgica. Não há informações sobre gravidade, evolução ou desfecho neste caso, impossibilitando detalhar a conduta ou o resultado clínico.

O medicamento Mabthera (princípio ativo: Rituximab) foi relacionado a um episódio de cegueira unilateral, descrito como manifestação de hipersensibilidade. Não há evidências de gravidade relevante relatadas e o desfecho permanece desconhecido, não sendo possível afirmar a evolução clínica do paciente.

O medicamento Levoid, cujo princípio ativo é a levotiroxina sódica, foi associado a um caso de cegueira unilateral, descrita como uma reação de hipersensibilidade (alergia) envolvendo o sistema imunológico. Embora a reação seja potencialmente preocupante por envolver perda de visão em um olho, não há evidências clínicas no registro que indiquem gravidade elevada, pois não foi classificada como grave e o desfecho é desconhecido. A relação com o

medicamento é considerada suspeita, e a conduta deve incluir avaliação médica imediata para investigação da causa e manejo adequado, conforme orientações para quadros alérgicos.

O medicamento Insulin, com princípio ativo insulina, está relacionado a um episódio de cegueira unilateral, caracterizado como hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. Apesar da gravidade potencial do sintoma, o registro não indica que o caso tenha sido considerado grave, e o desfecho permanece desconhecido. A relação com o medicamento é suspeita, sendo fundamental buscar avaliação médica urgente para esclarecer a causa e orientar o tratamento, seguindo recomendações para reações alérgicas medicamentosas.

O medicamento Prednisone, cujo princípio ativo é a prednisona, foi associado a um caso de cegueira unilateral, descrito como uma reação de hipersensibilidade (alergia) envolvendo o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada no registro, pois o caso não foi classificado como grave e o desfecho é desconhecido. A relação com o medicamento é suspeita, sendo recomendada avaliação médica imediata para investigação e manejo, conforme diretrizes para quadros alérgicos.

O medicamento Rosuvastatin, com princípio ativo rosuvastatina, está relacionado a um caso de cegueira unilateral, caracterizado como hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. O registro não aponta gravidade elevada, já que não foi classificado como grave e o desfecho é desconhecido. A relação com o medicamento é suspeita, sendo importante procurar avaliação médica para investigação e conduta adequada, conforme orientações para reações alérgicas medicamentosas.

O medicamento Riximyo, cujo princípio ativo é o rituximabe, foi associado a um episódio de cegueira unilateral, descrito como uma reação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. Apesar do sintoma ser relevante, não há evidência de gravidade aumentada no registro, pois não foi classificado como grave e o desfecho é desconhecido. A relação com o medicamento é suspeita, sendo indicada avaliação médica imediata para investigação e manejo, conforme recomendações para quadros alérgicos.

O medicamento Alglucosidase alfa, cujo princípio ativo também é Alglucosidase alfa, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), manifestado enquanto o paciente estava acamado. A reação foi classificada como relacionada a distúrbios do sistema imunitário, sem indicação de gravidade elevada, já que o paciente encontra-se em recuperação ou resolvendo o quadro. Não há menção de sintomas graves ou risco imediato, sugerindo um evento leve a moderado, compatível com reações alérgicas que requerem monitoramento e possível ajuste terapêutico, conforme as diretrizes da ASBAI.

O medicamento Meropenem, com princípio ativo Meropenem trihydrate, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), caracterizado como um distúrbio do sistema imunitário. Não há descrição de sintomas graves ou risco de vida, e o paciente está em recuperação ou resolvendo o quadro, o que indica uma reação de gravidade leve a moderada. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico e evitar reexposição ao medicamento, conforme orientações para reações alérgicas medicamentosas.

O medicamento Vancomicina, cujo princípio ativo é Vancomycin, foi associado a uma reação de hipersensibilidade (alergia), enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Não há relato de sintomas graves, e o paciente está em recuperação ou resolvendo o evento, sugerindo uma reação leve a moderada. A conduta adequada é suspender o uso do medicamento e monitorar a evolução clínica, conforme as recomendações para quadros alérgicos medicamentosos.

O medicamento Ciprobacter, com princípio ativo Ciprofloxacin, foi prescrito apesar de haver contraindicação documentada por hipersensibilidade prévia ao produto, caracterizando um erro de prescrição e um problema de monitoramento do tratamento. Não há informações sobre sintomas, gravidade ou desfecho, mas a situação exige imediata suspensão do medicamento e revisão do histórico alérgico do paciente para evitar riscos de reações adversas graves, conforme as diretrizes de segurança em farmacovigilância.



O medicamento Ciprobacter, cujo princípio ativo é Ciprofloxacina, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há detalhes sobre sintomas, gravidade ou evolução, mas a suspeita de alergia ao medicamento exige suspensão imediata do uso e avaliação médica para evitar complicações, seguindo as recomendações para reações alérgicas medicamentosas.

O medicamento Cloridrato de tramadol (princípio ativo: Tramadol hydrochloride) foi associado a um quadro de alergia, descrito tecnicamente como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou ação adotada, portanto, recomenda-se atenção a sintomas alérgicos e busca de avaliação médica para confirmação e conduta adequada.

A Prednisona (princípio ativo: Prednisone) foi relacionada ao aumento dos batimentos cardíacos, sendo classificada como uma reação de hipersensibilidade (alergia) dentro dos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente encontra-se em recuperação ou resolução do quadro, sugerindo que a reação foi leve e está evoluindo favoravelmente, sem necessidade de intervenções emergenciais.

O medicamento Reuquinol (princípio ativo: Hydroxychloroquine sulfate) apresentou como reação adversa o aumento dos batimentos cardíacos, classificado como hipersensibilidade (alergia) e enquadrado nos distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e está em processo de recuperação ou resolução, indicando que a reação foi leve e está sendo controlada, sem complicações relatadas.

O Alivium (princípio ativo: Ibuprofen) foi associado ao aumento dos batimentos cardíacos, caracterizado como uma reação de hipersensibilidade (alergia) relacionada a distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente está em recuperação ou resolução, sugerindo um quadro leve e autolimitado, sem necessidade de medidas urgentes.

O medicamento Benlysta (princípio ativo: Belimumab) foi relacionado ao aumento dos batimentos cardíacos, descrito como uma reação de hipersensibilidade (alergia) dentro dos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e está em recuperação ou resolução, indicando que a reação foi leve e está evoluindo de forma favorável, sem relatos de complicações.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, foi associado a um quadro de alergia a contraste, caracterizado como uma reação imunológica a substâncias químicas utilizadas em exames de imagem. Trata-se de um evento clinicamente significativo, considerado grave devido ao potencial de risco à saúde, mas o paciente evoluiu para recuperação completa após a reação.

O Gadovist (gadobutrol) também esteve relacionado a um episódio de edema de glote, que é um inchaço grave na região da garganta e pode comprometer a respiração, sendo considerado uma reação alérgica a contraste com risco de vida e necessidade de hospitalização. O paciente encontra-se em recuperação, o que reforça a gravidade do evento e a importância de acompanhamento médico imediato.

A prednisona, cujo nome comercial é Prednisona, foi associada ao surgimento de febre, interpretada como uma possível manifestação de hipersensibilidade (reação alérgica) do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, e o quadro permanece em andamento, sem resolução até o momento.

O medicamento Micofenolato de mofetila (mycophenolate mofetil) foi relacionado ao aparecimento de febre, considerada uma possível reação de hipersensibilidade do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade aumentada, e o paciente ainda não se recuperou, estando o quadro em evolução.

O Benlysta, cujo princípio ativo é o belimumabe, foi associado ao desenvolvimento de febre, interpretada como uma reação de hipersensibilidade do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade importante, e o paciente segue sem resolução completa do quadro até o momento.

O medicamento Benzetacil, cujo princípio ativo é a benzilpenicilina benzatina, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado por uma reação do sistema imunológico ao medicamento. Não há detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade, mas o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente. A conduta recomendada nesses casos é evitar novas exposições ao medicamento e buscar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O contraste Iobitridol, utilizado em exames de imagem, provocou uma reação alérgica (alergia a contraste), que é uma resposta do sistema imunológico ao agente administrado. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente. Em situações como essa, é importante informar a equipe médica sobre a alergia para evitar futuras exposições e considerar alternativas seguras em exames posteriores.

A vacina COVID-19 AstraZeneca (princípio ativo ChAdOx1 nCoV-19) foi relacionada a um episódio de dor lombar, classificado como hipersensibilidade, embora não haja detalhes sobre sintomas típicos de alergia ou gravidade. Não há informações sobre o desfecho ou conduta adotada. Em casos de suspeita de reação alérgica a vacinas, recomenda-se avaliação médica para esclarecimento do quadro e orientação sobre futuras doses.

O antibiótico Vancomicina (princípio ativo vancomicina) foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade), que é uma resposta do sistema imunológico ao medicamento. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente. A orientação nesses casos é evitar o uso futuro do medicamento e buscar avaliação especializada para confirmação da alergia e discussão de alternativas terapêuticas.

O imunizante Comirnaty (princípio ativo tozinamerana) foi utilizado em situação não descrita na bula (off label) e resultou em uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, considerada clinicamente significativa e grave, embora o desfecho seja desconhecido. Em situações de reações graves a medicamentos, é fundamental interromper a exposição, monitorar o paciente e encaminhar para avaliação especializada para investigação e manejo adequado.

O medicamento Ceftriaxona (princípio ativo: Ceftriaxone) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, caracterizado como uma reação alérgica envolvendo o sistema imunológico. Não há detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade, mas o desfecho foi de recuperação completa, indicando resolução do quadro após a suspensão ou manejo adequado do medicamento.

O medicamento Rinvoq (princípio ativo: Upadacitinib) foi relacionado a um evento de hipersensibilidade, classificado como reação alérgica, sem sintomas detalhados e sem gravidade significativa relatada. O paciente encontra-se em recuperação, sugerindo que a conduta adotada foi suficiente para controlar o quadro, sem evolução para complicações graves.

No caso da Dipirona (princípio ativo: Metamizole sodium), foi prescrito um produto contraindicado devido à hipersensibilidade previamente documentada ao medicamento, o que representa um erro de prescrição com potencial risco de reação alérgica. Não há informações sobre sintomas, gravidade ou desfecho, mas a situação exige atenção imediata para evitar exposição futura e possíveis complicações.

O medicamento Comirnaty (princípio ativo: Tozinameran) foi utilizado fora das indicações da bula (off label) e resultou em um quadro de hipersensibilidade, considerado clinicamente significativo e grave, embora não haja detalhes sobre sintomas ou evolução. O desfecho permanece desconhecido, indicando a necessidade de acompanhamento e avaliação médica rigorosa diante do risco potencial.

O medicamento Peg-lax (princípio ativo: Macrogol 3350) foi associado a uma alergia relacionada ao uso de dispositivo, caracterizada como uma reação alérgica grave com ameaça à vida. O quadro permanece em andamento, sem recuperação até o momento, o que reforça a necessidade de intervenção médica imediata e monitoramento contínuo para evitar complicações maiores.

O medicamento Acetaminofen, cujo princípio ativo é Paracetamol, foi associado a um quadro de alergia relacionada ao uso de dispositivo, caracterizado como uma reação alérgica grave com ameaça à vida, conforme evidenciado pela classificação de gravidade e pelo fato de o paciente não ter se recuperado até o momento. A reação envolve o sistema imunológico e requer atenção imediata, sendo fundamental acompanhamento médico especializado para manejo adequado, já que o desfecho permanece em andamento.

O medicamento Berotec, com princípio ativo Fenoterol hydrobromide, apresentou um caso de alergia a dispositivo, que é uma reação alérgica grave e potencialmente fatal, como indicado pela gravidade relatada e pela ausência de resolução do quadro. Trata-se de uma manifestação imunológica que demanda intervenção médica urgente, pois o paciente ainda não se recuperou e a situação permanece em evolução.

A Loratadina, cujo princípio ativo é Loratadine, foi relacionada a um episódio de alergia a dispositivo, considerado de ameaça à vida devido à gravidade do quadro e ao fato de o paciente não ter apresentado recuperação até o momento. Essa reação envolve o sistema imunológico e exige avaliação médica imediata, já que o desfecho segue não resolvido.

O medicamento Furosemida, com princípio ativo Furosemide, esteve envolvido em um caso de alergia a dispositivo, classificado como uma reação alérgica grave com risco à vida, evidenciado pela gravidade do evento e pela ausência de recuperação do paciente. A situação requer acompanhamento médico rigoroso, pois o quadro permanece em andamento.

O medicamento Captopril, cujo princípio ativo é Captopril, foi associado a uma reação de alergia a dispositivo, considerada de ameaça à vida, conforme a gravidade relatada e o fato de o paciente ainda não ter se recuperado. Trata-se de uma resposta imunológica importante que necessita de avaliação e manejo médico imediato, já que o desfecho segue em andamento.

O medicamento Espironolactona (princípio ativo: Spironolactone) foi associado a um quadro de alergia a dispositivo, classificado como uma reação alérgica grave com ameaça à vida, conforme evidenciado pela gravidade relatada e pelo fato de o paciente não ter se recuperado até o momento. A reação envolve o sistema imunológico e requer atenção médica imediata, sendo fundamental interromper o uso do dispositivo suspeito e buscar avaliação especializada para manejo adequado.

O medicamento Seretide, que contém os princípios ativos Fluticasone propionate e Salmeterol xinafoate, foi relacionado a um episódio de alergia a dispositivo, considerado de ameaça à vida devido à gravidade informada e ao desfecho ainda não resolvido. Trata-se de uma reação imunológica importante, exigindo suspensão do uso do dispositivo e acompanhamento médico urgente para evitar complicações maiores.

O medicamento Naglazyme (princípio ativo: Galsulfase) apresentou um caso de alergia a dispositivo, classificado como reação alérgica grave com risco à vida, já que o paciente permanece sem recuperação. A situação demanda suspensão imediata do uso do dispositivo e avaliação médica especializada para controle da reação e prevenção de agravamento.

O medicamento Omnipaque (princípio ativo: Iohexol) foi associado a uma alergia a contraste, reação que envolve o sistema imunológico, mas neste caso o paciente se recuperou totalmente. A conduta adequada inclui a suspensão do agente suspeito e monitoramento dos sintomas, sendo importante informar a equipe médica sobre o episódio em futuras exposições a contrastes.

O medicamento Etravirina (princípio ativo: Etravirine) foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa, descrito como resistência viral, sem gravidade relatada e com desfecho desconhecido. A reação envolve o sistema imunológico e, diante da incerteza sobre a evolução, recomenda-se acompanhamento médico para monitoramento e ajuste do tratamento, se necessário.

O medicamento Darunavir, cujo princípio ativo é Darunavir Ethanolate, foi associado a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa, que se manifesta como uma reação alérgica do sistema imunológico a medicamentos. Não há indicação de gravidade elevada ou necessidade de hospitalização neste caso, e o desfecho da reação é desconhecido. A relação entre o medicamento e a reação foi considerada suspeita, sendo importante monitorar sintomas e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre o uso futuro do medicamento.

Tivicay, que contém o princípio ativo Dolutegravir sodium, esteve relacionado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, caracterizado por uma resposta alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Não há informações sobre gravidade significativa ou necessidade de internação, e o desfecho permanece desconhecido. A suspeita de relação entre o medicamento e a reação reforça a importância de acompanhamento clínico para avaliação de sintomas e definição de conduta adequada.

A Oxaliplatina, cujo princípio ativo é Oxaliplatin, foi associada a um quadro de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Não há evidências de gravidade aumentada ou necessidade de hospitalização, e o paciente evoluiu para recuperação completa após o evento. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, sendo fundamental o acompanhamento médico para evitar novas exposições e orientar futuras condutas terapêuticas.

No caso da Oxaliplatina (princípio ativo Oxaliplatin), houve relato de hipersensibilidade, que corresponde a uma reação alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Não foram observados sinais de gravidade ou necessidade de internação, e o paciente se recuperou totalmente após o episódio. A relação entre o medicamento e a reação foi considerada suspeita, recomendando-se avaliação médica para confirmação diagnóstica e prevenção de novas reações.

O medicamento Iobitridol, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a uma alergia a contraste intravenoso, caracterizada por uma reação alérgica do sistema imunológico após exposição ao contraste. Neste caso, a gravidade foi considerada elevada, pois houve necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando um quadro clínico mais sério. O paciente se recuperou após o evento, e a relação entre o uso do contraste e a reação foi considerada suspeita, sendo fundamental evitar novas exposições e garantir acompanhamento médico especializado para manejo seguro em futuras necessidades de exames com contraste.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, foi associado a uma reação anafilática ao meio de contraste, caracterizada por hipersensibilidade (alergia) e classificada como um quadro clínico alérgico relevante. A gravidade do evento é evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, além de ser considerado clinicamente significativo. O paciente se recuperou totalmente após a reação, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Diazepam, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um episódio de alergia a contraste, manifestando-se como uma reação alérgica relevante do sistema imunológico. O caso foi considerado clinicamente significativo, indicando gravidade, e o paciente evoluiu para recuperação completa. A relação entre o uso do medicamento e a reação é suspeita.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, esteve envolvido em uma reação de alergia a contraste, caracterizada por resposta alérgica do sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente significativo, indicando gravidade, e o paciente se recuperou totalmente após o episódio. A relação com o medicamento é suspeita.

O medicamento Gadovist, com princípio ativo gadobutrol, foi associado a uma reação de alergia a contraste, evidenciando uma resposta alérgica do sistema imunológico. O caso foi considerado clinicamente significativo, o que indica gravidade, e o paciente apresentou recuperação completa. A relação entre o medicamento e a reação é suspeita.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, esteve relacionado a uma reação de alergia a contraste, manifestando-se como resposta alérgica do sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente significativo, indicando gravidade, e o paciente se recuperou totalmente. A relação com o medicamento é suspeita.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, foi associado a um episódio de alergia a contraste, reação que envolve o sistema imunológico e pode ser clinicamente significativa, conforme evidenciado pela classificação de gravidade e pelo fato de ter sido considerada grave. O paciente apresentou recuperação completa após o evento, indicando resolução do quadro após as medidas adotadas.

O Gadovist (gadobutrol) também esteve relacionado a outro caso de alergia a contraste, caracterizada por uma resposta do sistema imunológico a substâncias químicas presentes no contraste utilizado em exames. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, mas o paciente se recuperou totalmente após o episódio.

O medicamento Ultravist, com princípio ativo iopromida, foi responsável por uma reação de alergia a contraste, que é uma resposta imunológica adversa a substâncias químicas administradas durante exames de imagem. O evento foi classificado como clinicamente significativo e grave, porém o paciente evoluiu para recuperação completa após o ocorrido.

No caso da Dipirona (princípio ativo metamizol monohidratado), houve prescrição de um produto contraindicado devido à hipersensibilidade documentada ao medicamento, o que representa um erro de prescrição com potencial risco de reações adversas, embora não haja detalhes sobre a gravidade, evolução ou desfecho do caso.

O medicamento Xarelto, cujo princípio ativo é o rivaroxabana, foi associado a um episódio de fraqueza relacionado à hipersensibilidade medicamentosa, uma reação do sistema imunológico considerada clinicamente significativa e grave, mas que evoluiu para recuperação completa do paciente após o evento.

O medicamento Tramal retard, cujo princípio ativo é o tramadol hydrochloride, foi associado a um episódio de fraqueza interpretado como hipersensibilidade medicamentosa (alergia ao medicamento). A reação foi considerada clinicamente significativa, pois foi classificada como grave, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. Situações como essa exigem atenção médica para avaliação da relação causal e orientação sobre o uso futuro do medicamento.

O medicamento Nactali, que contém desogestrel como princípio ativo, foi relacionado ao aparecimento de sangue nas fezes, sendo o evento associado a uma possível alergia ao leite. Apesar de não ter sido classificado como grave, o quadro ainda está em andamento, sem resolução até o momento, o que indica a necessidade de acompanhamento médico para investigação da causa e manejo adequado.

O medicamento Alteplase, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), mas não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente após o evento. Mesmo em casos leves, é importante relatar reações alérgicas a medicamentos para evitar futuras exposições e orientar o tratamento.

A vacina COVID-19 AstraZeneca (princípio ativo: COVID-19 vaccine NRVV Ad - ChAdOx1 nCoV-19) foi associada ao surgimento de erupção cutânea, interpretada como manifestação alérgica. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, embora o desfecho ainda seja desconhecido, o que reforça a importância de acompanhamento médico para monitoramento e orientação sobre futuras doses ou alternativas vacinais.

O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é tozinameran, foi utilizado de forma não descrita em bula (off label) e associado a uma reação de alergia à vacina. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, com desfecho ainda desconhecido, indicando a necessidade de avaliação médica criteriosa para monitorar possíveis complicações e orientar condutas futuras.

O medicamento Copaxone teva, cujo princípio ativo é o acetato de glatirâmer, foi associado a uma recidiva de esclerose múltipla, sendo classificado como um quadro de hipersensibilidade (alergia) relacionado a distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A conduta deve envolver avaliação clínica detalhada para confirmar a relação causal e monitorar possíveis reações alérgicas, conforme orientação especializada.

O Cetoprofeno, cujo princípio ativo é o cetoprofeno sódico, foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou ação adotada, e a reação foi considerada uma possível interação. Recomenda-se atenção clínica para sintomas alérgicos e avaliação médica para confirmação e orientação adequada.

O medicamento Pantoprazole, com princípio ativo pantoprazol, foi associado a uma reação descrita como queda, relacionada a alergia a iodo, dentro do contexto de distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa ou desfecho informado, e a relação com o medicamento é suspeita. É importante investigar a possível relação entre o uso do medicamento e sintomas alérgicos, buscando orientação médica para esclarecimento.

O Levothyroxine, cujo princípio ativo é levotiroxina, foi relacionado a uma reação de queda, atribuída a alergia a iodo, classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade relevante ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Recomenda-se avaliação clínica para investigar a possível associação e orientar conduta adequada.

O Glifage XR, com princípio ativo cloridrato de metformina, foi associado a uma reação de queda, descrita como alergia a iodo, dentro do grupo de distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade importante ou desfecho, e a relação com o medicamento é suspeita. É indicado acompanhamento clínico para avaliar a relação causal e definir a melhor conduta.

O medicamento Hydrochlorothiazide, cujo princípio ativo é hydrochlorothiazide, foi associado a uma reação descrita como alergia a iodo, classificada entre as alergias a alimentos, aditivos alimentares, medicamentos e outras substâncias químicas, afetando o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e não foram relatadas ações específicas adotadas. A ausência de sinais de gravidade e de evolução clínica sugere que a reação foi leve, mas é importante considerar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação adequada.

O medicamento Amlodipine, com princípio ativo amlodipine, foi relacionado a uma reação de alergia a iodo, enquadrada entre alergias a substâncias químicas e medicamentos, com envolvimento do sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade significativa, desfecho ou conduta adotada, o que sugere um quadro leve, mas recomenda-se acompanhamento clínico para esclarecimento e manejo apropriado.

O medicamento Actemra, cujo princípio ativo é tocilizumab, foi associado a uma reação de alergia a iodo, pertencente ao grupo de alergias a medicamentos e outras substâncias químicas, afetando o sistema imunológico. Não há registro de gravidade importante, desfecho ou medidas tomadas, indicando que a reação provavelmente foi leve, mas é fundamental buscar avaliação médica para confirmação e orientação sobre futuras exposições.

O medicamento Pantoprazol, com princípio ativo pantoprazole, foi relacionado a uma reação de alergia a iodo, classificada entre alergias a medicamentos e substâncias químicas, com envolvimento do sistema imunológico. Não há dados sobre gravidade, desfecho ou conduta, sugerindo um quadro leve, mas é recomendável avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição de conduta segura.

O medicamento Levotiroxina, cujo princípio ativo é levothyroxine, foi associado a uma reação de alergia a iodo, enquadrada entre alergias a medicamentos e outras substâncias químicas, com impacto no sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou ações tomadas, o que sugere um quadro leve, sendo importante

buscar avaliação médica para esclarecimento e orientação quanto ao uso futuro do medicamento.

O medicamento Glifage XR, cujo princípio ativo é o cloridrato de metformina, foi associado a uma reação descrita como 'queda' em um paciente com histórico de alergia a iodo. Embora não haja detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade clínica, a reação foi classificada como relacionada a distúrbios do sistema imunitário, sugerindo possível envolvimento alérgico. Não há informações sobre a evolução do quadro ou conduta adotada, e o desfecho permanece desconhecido.

A hidroclorotiazida, cujo princípio ativo é hydrochlorothiazide, foi relacionada a um episódio de 'queda' em paciente com alergia a iodo. A reação foi categorizada como distúrbio do sistema imunitário, sugerindo possível componente alérgico, mas não há detalhes sobre sintomas, gravidade ou evolução clínica. O desfecho do caso não foi informado e não há registro de conduta adotada.

O medicamento Amlodipina, com princípio ativo besilato de amlodipina, foi associado a uma reação descrita como 'queda' em paciente com alergia a iodo. A reação foi enquadrada como distúrbio do sistema imunitário, indicando possível relação com hipersensibilidade, mas não há detalhes sobre sintomas, gravidade ou evolução. O desfecho permanece desconhecido e não há informações sobre medidas tomadas.

O Actemra, cujo princípio ativo é tocilizumabe, foi relacionado a uma reação de 'queda' em paciente com alergia a iodo. A reação foi classificada como distúrbio do sistema imunitário, sugerindo possível envolvimento alérgico, mas não há detalhes sobre sintomas específicos, gravidade, conduta adotada ou evolução clínica. O desfecho do caso não foi informado.

O medicamento Frontal, que contém alprazolam como princípio ativo, foi associado a um quadro de alergia sistêmica (SOE) classificado como hipersensibilidade, com gravidade significativa evidenciada por ameaça à vida e necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação. Trata-se de uma reação alérgica grave envolvendo o sistema imunitário, mas não há detalhes sobre a conduta adotada ou o desfecho do caso.

O medicamento Dorflex, que contém cafeína, metamizol sódico e citrato de orfenadrina, foi associado a um quadro de alergia grave, caracterizado por hipersensibilidade (alergia SOE), com risco de ameaça à vida e necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação. A gravidade é sustentada pela descrição de ameaça à vida e hospitalização, sendo fundamental a suspensão imediata do medicamento e acompanhamento médico rigoroso, embora o desfecho não tenha sido informado.

Ocrevus, cujo princípio ativo é ocrelizumabe, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), mas não há detalhes sobre a gravidade, evolução ou desfecho do caso. A ausência dessas informações impede uma avaliação mais precisa da conduta e do risco, sendo recomendada atenção clínica e investigação de sintomas alérgicos durante o uso.

O medicamento Clindoxyl Control, à base de peróxido de benzoíla, desencadeou uma reação alérgica medicamentosa (hipersensibilidade), considerada clinicamente significativa, o que indica a necessidade de suspensão do uso e avaliação médica para manejo dos sintomas, embora o desfecho não tenha sido informado.

Iomeron, que contém iomeprol, foi associado a edema laríngeo, uma reação alérgica que pode comprometer as vias aéreas, mas neste caso foi classificada como não grave e o paciente se recuperou totalmente após a conduta adotada, sem necessidade de hospitalização prolongada.

A vancomicina, antibiótico cujo princípio ativo é a vancomicina, foi relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), considerado não grave, com resolução completa dos sintomas após a suspensão do medicamento, sem complicações adicionais.

O medicamento COVID-19 vaccine AstraZeneca, cujo princípio ativo é COVID-19 vaccine NRVV Ad (ChAdOx1 nCoV-19), foi associado a um quadro de resfriado interpretado como hipersensibilidade, dentro do contexto de reações alérgicas do sistema imune. Não há indicação de gravidade elevada, pois o evento foi classificado como não grave e o paciente se recuperou totalmente. A relação com o medicamento foi concomitante, sugerindo que o sintoma ocorreu durante o uso, e não há necessidade de conduta adicional além do acompanhamento clínico, já que o desfecho foi resolutivo.

O medicamento Reuquinol, cujo princípio ativo é hydroxychloroquine sulfate, esteve relacionado a episódios recorrentes de infecção do trato urinário, classificados como hipersensibilidade e incluídos em quadros clínicos alérgicos do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou completamente, e a relação com o medicamento foi suspeita. Diante da ausência de gravidade e da resolução do quadro, a conduta recomendada é manter o acompanhamento clínico e reavaliar a necessidade do uso do medicamento em caso de recorrência dos sintomas.

O medicamento Paracetamol, com princípio ativo de mesmo nome, foi associado a infecção do trato urinário recorrente, interpretada como manifestação de hipersensibilidade e incluída em quadros alérgicos do sistema imune. O evento não foi considerado grave, pois houve recuperação completa do paciente, e a relação com o medicamento foi suspeita. Como o quadro se resolveu sem complicações, recomenda-se apenas observação clínica e reavaliação do uso do medicamento caso os sintomas retornem.

O medicamento Azithromycin, cujo princípio ativo também é azithromycin, esteve relacionado a infecção do trato urinário recorrente, considerada manifestação de hipersensibilidade e classificada como quadro alérgico do sistema imunológico. O evento não foi grave, pois o paciente se recuperou totalmente, e a relação com o medicamento foi suspeita. Diante da resolução do quadro e ausência de gravidade, a conduta é manter acompanhamento clínico e avaliar a necessidade de uso do medicamento em situações futuras.

O medicamento Prednisolone, com princípio ativo de mesmo nome, foi associado a infecção do trato urinário recorrente, interpretada como manifestação de hipersensibilidade e incluída em quadros clínicos alérgicos do sistema imune. O evento não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou completamente, e a relação com o medicamento foi suspeita. Como o quadro se resolveu sem complicações, recomenda-se apenas observação clínica e reavaliação do uso do medicamento caso haja recorrência dos sintomas.

O medicamento Benlysta, cujo princípio ativo é o belimumabe, esteve associado a episódios recorrentes de infecção do trato urinário, classificados como quadros de hipersensibilidade (alergia) relacionados ao sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi resolvido sem complicações e o paciente se recuperou totalmente. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico para monitorar possíveis recorrências, mas não há necessidade de intervenções emergenciais, visto que o desfecho foi favorável.

O Dotarem, que contém meglumina gadoterato como princípio ativo, foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), também classificado como reação alérgica do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade significativa, já que o paciente se recuperou completamente após o evento. A orientação é observar possíveis reações futuras e buscar avaliação médica caso ocorram novos sintomas, mas o episódio foi resolvido sem consequências graves.

O medicamento Ondansetron, com o mesmo princípio ativo, esteve envolvido em um episódio de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como reação do sistema imunológico. O caso não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou totalmente. Recomenda-se atenção a possíveis reações futuras, mas não houve necessidade de medidas emergenciais, já que o desfecho foi resolutivo.

A Neocaina pesada, composta por bupivacaína e glicose, foi associada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), enquadrado como reação do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade, pois o paciente se recuperou sem complicações. A conduta é manter vigilância para novas reações, mas o evento foi autolimitado.



e não exigiu intervenções adicionais.

O Omnipaque, cujo princípio ativo é o iohexol, foi relacionado a uma alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), classificada como reação do sistema imunológico a medicamentos. O episódio não foi considerado grave, já que o paciente se recuperou completamente. Recomenda-se evitar novas exposições ao agente e buscar avaliação médica em caso de sintomas, mas o evento foi resolvido sem complicações.

O medicamento Meropenem, cujo princípio ativo é o meropenem trihydrate, foi associado a um quadro de urticária, caracterizando uma reação de hipersensibilidade (alergia) do tipo cutânea, que se manifesta por lesões avermelhadas e coceira na pele. Embora a gravidade não tenha sido explicitada, a urticária é geralmente considerada uma reação leve a moderada, mas pode indicar risco aumentado para reações mais graves em exposições futuras. A conduta recomendada é interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas terapêuticas, além de evitar reexposição ao meropenem.

O medicamento Dramin b6, composto por dimenidrinato e cloridrato de piridoxina, foi relacionado ao desenvolvimento de febre reumática, descrita como uma manifestação de hipersensibilidade (alergia sistêmica). Apesar de não ter sido classificada como grave e o desfecho estar em andamento, a febre reumática é uma condição que exige acompanhamento médico, pois pode afetar articulações e o coração. Recomenda-se suspender o uso do medicamento suspeito e procurar avaliação médica para investigação e manejo adequado da reação.

O medicamento Luftal, cujo princípio ativo é o simeticone, foi associado a um caso de febre reumática, considerada uma reação de hipersensibilidade sistêmica. Não há indicação de gravidade elevada e o quadro permanece não resolvido até o momento. Diante desse tipo de reação, é importante interromper o uso do simeticone e buscar orientação médica para avaliação detalhada e definição do tratamento, além de evitar reexposição ao medicamento.

O medicamento Reuquinol, que contém o princípio ativo sulfato de hidroxycloquina, foi relacionado ao surgimento de febre reumática, caracterizando uma reação de hipersensibilidade sistêmica. O evento não foi considerado grave e o desfecho permanece em andamento. Diante desse quadro, recomenda-se suspender o uso do medicamento e procurar avaliação médica para investigação da reação e orientação sobre alternativas terapêuticas.

O medicamento Prednisone, cujo princípio ativo é a própria prednisona, foi associado a um episódio de febre reumática, interpretado como uma reação de hipersensibilidade sistêmica. Não há indicação de gravidade elevada e o quadro segue não resolvido. A conduta recomendada é interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e definição do melhor manejo, evitando reexposição à prednisona.

O medicamento Ibuprofen (princípio ativo: Ibuprofen) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, manifestado como febre reumática, o que indica uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois não há relato de complicações graves ou risco imediato à vida, e o caso permanece em andamento, sem resolução até o momento. A conduta recomendada é a suspensão do medicamento e acompanhamento clínico, com avaliação de um especialista para confirmação diagnóstica e definição do melhor manejo, conforme orientações da ASBAI para quadros alérgicos leves a moderados.

Azatioprina (princípio ativo: Azathioprine) foi relacionada a um episódio de hipersensibilidade, descrito como febre reumática, caracterizando uma resposta alérgica do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade importante, já que não foram relatadas complicações graves, e o quadro segue sem resolução. Recomenda-se interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica especializada para investigação e controle da reação, seguindo as diretrizes para reações alérgicas leves a moderadas.

O medicamento Benlysta (princípio ativo: Belimumab) apresentou associação com hipersensibilidade, manifestada como febre reumática, indicando uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade significativa, pois não foram relatadas complicações graves, e o caso permanece em andamento. A orientação é suspender o uso do medicamento e realizar acompanhamento médico para avaliação e manejo adequado, conforme recomendações para quadros alérgicos leves a moderados.

Carboplatina (princípio ativo: Carboplatin) foi associada a um episódio de hipersensibilidade, descrito genericamente como alergia, envolvendo o sistema imunológico. O caso não foi considerado grave, pois não houve relato de complicações importantes e o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente. A conduta adequada inclui a suspensão do medicamento e acompanhamento clínico, com avaliação de especialista se necessário, conforme orientações para reações alérgicas leves.

Paclitaxel (princípio ativo: Paclitaxel) esteve relacionado a uma reação de hipersensibilidade, descrita como alergia, envolvendo o sistema imunológico. Não há indícios de gravidade relevante, já que não foram relatadas complicações graves e o paciente se recuperou totalmente. A recomendação é interromper o uso do medicamento e realizar acompanhamento clínico, seguindo as orientações para quadros alérgicos leves.

O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é o Tozinameran, foi associado a um quadro de alergia agravada (hipersensibilidade), manifestando-se como um distúrbio do sistema imunitário. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, pois permanece em andamento sem resolução até o momento, indicando necessidade de acompanhamento médico especializado para controle da alergia e monitoramento da evolução.

O Gadolinium, utilizado como agente de contraste, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade) classificada como clinicamente significativa e grave, evidenciada pela necessidade de intervenção médica, mas o paciente evoluiu para recuperação completa após a reação, não havendo sequelas relatadas.

O medicamento Secukinumab, com princípio ativo de mesmo nome, provocou sensação de queimação na face, caracterizada como uma reação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunitário, porém não foi considerada grave e o desfecho permanece desconhecido, sendo importante monitorar o paciente para avaliar a necessidade de condutas adicionais.

O contraste Ultravist, cujo princípio ativo é o Iopromide, foi relacionado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunitário, mas não foi considerada grave e o paciente se recuperou totalmente após o evento, não sendo necessária intervenção adicional.

A vacina influenza trivalente, com princípio ativo Influenza vaccine inact sAg 3v, desencadeou uma reação alérgica documentada ao produto administrado, caracterizada como hipersensibilidade, mas não há informações suficientes sobre gravidade, conduta adotada ou desfecho, sendo recomendada avaliação médica caso sintomas persistam ou se agravem.

A Vacina influenza trivalente, cujo princípio ativo é Influenza vaccine inact sAg 3v, foi associada a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como clinicamente significativo devido à gravidade relatada. O evento foi considerado grave, com evolução ainda não resolvida, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico especializado para monitoramento e manejo adequado da reação alérgica, conforme orientações da ASBAI para quadros de hipersensibilidade a vacinas.

O medicamento Belimumab, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um episódio de pneumonia, descrito sob o contexto de hipersensibilidade. Apesar de não ter sido classificado como grave e o desfecho ser desconhecido, a associação entre o uso do imunobiológico e sintomas respiratórios sugere a importância de avaliação clínica detalhada para descartar reações alérgicas sistêmicas, conforme recomendações para quadros respiratórios associados a medicamentos.

A Dipirona (Metamizole sodium) esteve envolvida em um erro de prescrição, resultando em um quadro de hipersensibilidade, mas sem gravidade relatada e com resolução completa do evento. O paciente recuperou-se totalmente, indicando que a conduta adotada foi eficaz, mas reforçando a importância de evitar erros de prescrição para prevenir reações adversas, conforme orientações de segurança em farmacovigilância.

O imunizante Comirnaty, cujo princípio ativo é Tozinameran, foi associado ao desenvolvimento de febre em um contexto de hipersensibilidade, sendo o evento considerado clinicamente significativo e grave. O desfecho foi de recuperação com sequelas, o que destaca a necessidade de monitoramento rigoroso e acompanhamento médico após reações adversas graves a vacinas, conforme as diretrizes para eventos imunológicos relevantes.

A vacina COVID-19 AstraZeneca (princípio ativo COVID-19 vaccine NRVV Ad - ChAdOx1 nCoV-19) foi relacionada ao surgimento de febre em um quadro de hipersensibilidade, classificado como clinicamente significativo e grave. O paciente evoluiu para recuperação com sequelas, o que indica a importância de avaliação médica detalhada e acompanhamento após reações adversas graves a vacinas, seguindo as recomendações para manejo de eventos imunológicos relevantes.

O medicamento Azorga, que contém brinzolamida e maleato de timolol, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como um distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, pois houve indicação de outro efeito clinicamente relevante, embora o desfecho seja desconhecido. Diante de reações alérgicas graves, recomenda-se a suspensão imediata do medicamento e avaliação médica urgente para manejo adequado.

O medicamento Benlysta, cujo princípio ativo é o belimumabe, foi relacionado a um caso de síndrome nefrótica associada a hipersensibilidade, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Apesar da gravidade potencial da síndrome nefrótica, neste registro não há indicação de gravidade clínica relevante e o desfecho permanece desconhecido. É importante monitorar sintomas e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e conduta apropriada.

O medicamento Xolair, que tem como princípio ativo o omalizumabe, foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando resolução do quadro após a reação adversa.

O medicamento Xolair, com princípio ativo omalizumabe, esteve relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), considerado clinicamente significativo e grave devido à presença de outro efeito relevante, sem resolução até o momento do registro. Em situações de alergia grave, é fundamental interromper o uso do medicamento e buscar atendimento médico imediato para avaliação e tratamento.

O medicamento Amoxicilina + clavulanato de potássio, composto por amoxicilina tri-hidratada e clavulanato de potássio, foi associado a uma reação de hipersensibilidade manifestada por sensação anormal, classificada como distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, e o paciente encontrava-se em recuperação no momento do registro. Nesses casos, recomenda-se suspensão do medicamento e acompanhamento médico rigoroso para manejo da reação alérgica.

O medicamento Paco, que contém codeína fosfato e paracetamol, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia) manifestado como diabetes, embora não haja detalhes sobre sintomas específicos. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, pois não houve recuperação até o momento, indicando que o quadro permanece em andamento. A relação entre o uso do medicamento e o evento adverso é suspeita, sendo fundamental acompanhamento médico para monitoramento e manejo adequado da reação.

O Bupropion, cujo princípio ativo é o próprio bupropion, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia) descrito como diabetes, sem detalhes adicionais sobre sintomas. A gravidade foi classificada como clinicamente significativa e grave, já que o paciente não apresentou resolução do quadro, permanecendo em

evolução. O evento é considerado suspeito em relação ao uso do medicamento, sendo necessária avaliação médica contínua para controle da reação.

O medicamento Mabthera, que tem como princípio ativo o rituximabe, foi associado a uma reação de hipersensibilidade (alergia) descrita como diabetes, sem especificação de sintomas clínicos. O caso foi considerado grave e clinicamente relevante, pois não houve resolução até o momento, permanecendo em andamento. A relação entre o uso do Mabthera e o evento adverso é suspeita, recomendando-se acompanhamento médico rigoroso para avaliação e manejo da reação.

A cisplatina, cujo princípio ativo é cisplatin, foi relacionada a um episódio de hipersensibilidade (alergia), sem detalhamento de sintomas, mas o quadro foi resolvido após a conduta adotada, não sendo considerado grave. O paciente se recuperou totalmente, e a relação entre o uso do medicamento e a reação é suspeita, não havendo necessidade de intervenções adicionais no momento.

O medicamento Carboplatina, com princípio ativo carboplatin, esteve associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), sem descrição de sintomas específicos, mas o evento foi resolvido e não foi considerado grave. O paciente se recuperou completamente, e a relação com o uso do medicamento é suspeita, não sendo necessária conduta adicional após a resolução do quadro.

O medicamento COVID-19 vaccine AstraZeneca, cujo princípio ativo é COVID-19 vaccine NRVV Ad (ChAdOx1 nCoV-19), foi associado a um quadro de dor relacionado à hipersensibilidade (alergia), classificado como clinicamente significativo devido à gravidade informada e ao envolvimento do sistema imunológico. O paciente encontra-se em recuperação, indicando que a reação está se resolvendo. A conduta recomendada é acompanhamento clínico até resolução completa, com atenção a sinais de agravamento, conforme diretrizes para quadros alérgicos sistêmicos.

O medicamento Cyclosporine, com princípio ativo Ciclosporin, foi relacionado a uma infecção de pele atribuída à hipersensibilidade (alergia), envolvendo o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, e o quadro permanece em andamento, sem resolução até o momento. Recomenda-se avaliação médica para monitoramento da evolução e ajuste do tratamento, considerando a possibilidade de persistência da reação.

O medicamento Oxaliplatina, com princípio ativo Oxaliplatin, foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade) envolvendo o sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade aumentada, e o paciente já se encontra recuperado, indicando resolução completa do quadro. A conduta é manter acompanhamento clínico para prevenção de novas reações em futuras exposições.

O medicamento Docetaxel, cujo princípio ativo é Docetaxel, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade) envolvendo o sistema imunológico. Não há registro de gravidade relevante, e o paciente já está recuperado, demonstrando resolução do evento. Recomenda-se apenas acompanhamento clínico para evitar recorrências.

O medicamento Meronem, com princípio ativo Meropenem trihydrate, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade) envolvendo o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade aumentada, e o paciente já se encontra recuperado, sugerindo resolução do quadro. A conduta é manter vigilância clínica em caso de necessidade futura de reexposição ao medicamento.

O medicamento Clobazam, cujo princípio ativo também é clobazam, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, pois o paciente foi considerado recuperado ou resolvido após o evento, sugerindo uma reação leve e autolimitada. A conduta adequada envolve a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento clínico para evitar novas exposições.

A Rifampicina, cujo princípio ativo é rifampicin, foi relacionada a um episódio de alergia descrito como hipersensibilidade, enquadrado entre os distúrbios do sistema imunitário. Não há informações que indiquem gravidade importante, e o paciente encontra-se em recuperação ou resolvendo o quadro, o que sugere uma reação de intensidade leve a moderada. Recomenda-se evitar novas exposições ao medicamento e manter acompanhamento médico até resolução completa dos sintomas.

O medicamento Cefepime, com princípio ativo cefepime, foi associado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa, já que o paciente está em recuperação ou resolvendo o quadro, indicando uma reação provavelmente leve ou moderada. A orientação é suspender o uso do medicamento suspeito e monitorar a evolução clínica até a completa resolução dos sintomas.

Teicoplanina, cujo princípio ativo é teicoplanin, foi relacionada a um episódio de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade importante, pois o paciente está em recuperação ou resolvendo o quadro, sugerindo uma reação leve ou moderada. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e manter acompanhamento médico até a resolução total dos sintomas.

O medicamento Nipride, com princípio ativo nitroprusside sodium, foi associado a um quadro de alergia descrito como hipersensibilidade, classificado entre os distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, portanto não é possível afirmar a intensidade da reação ou a evolução clínica. A recomendação é suspender o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para monitoramento e definição da conduta adequada.

O medicamento Docetaxel, cujo princípio ativo também é docetaxel, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente. A conduta recomendada em situações semelhantes é observar sinais de alergia, evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras administrações.

O medicamento Omniscan, com princípio ativo gadodiamida, esteve relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação imunológica. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente. Em casos como este, recomenda-se evitar reexposição ao agente suspeito e procurar orientação médica para avaliação e confirmação da alergia, além de discutir alternativas seguras para exames futuros que exijam contraste.

A vacina COVID-19 AstraZeneca, cujo princípio ativo é a vacina COVID-19 NRVV Ad (ChAdOx1 nCoV-19), foi associada a um episódio de febre, interpretado como manifestação de hipersensibilidade do sistema imunológico. Não há evidência de gravidade aumentada, pois o evento não foi classificado como grave e o desfecho permanece desconhecido. Em situações semelhantes, recomenda-se monitorar os sintomas, buscar avaliação médica se houver piora ou persistência e relatar o evento para acompanhamento adequado.

O medicamento Annita, com princípio ativo nitazoxanida, foi relacionado a um episódio de febre, considerado manifestação de hipersensibilidade (alergia) pelo sistema imunológico. O evento não foi classificado como grave e o desfecho é desconhecido. Nessas situações, é importante monitorar a evolução dos sintomas e procurar avaliação médica caso haja agravamento, além de evitar o uso do medicamento até esclarecimento diagnóstico.

O medicamento Vitamina C, cujo princípio ativo é ácido ascórbico, esteve associado a um episódio de febre, interpretado como possível reação de hipersensibilidade do sistema imunológico. O caso não foi considerado grave e o desfecho permanece desconhecido. Recomenda-se observar a evolução dos sintomas, evitar nova exposição ao agente suspeito e buscar orientação médica para avaliação e confirmação diagnóstica se necessário.

O medicamento Vitamina D, cujo princípio ativo é o colecalciferol, foi associado a um episódio de febre interpretado como possível reação de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta exagerada do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo importante monitorar sintomas e buscar avaliação médica caso haja piora ou persistência.

O medicamento Fluir, que contém formoterol fumarato como princípio ativo, foi relacionado a um quadro de febre, sugerindo uma possível reação de hipersensibilidade (alergia). Não há sinais de gravidade importante ou informações sobre o desfecho, e a ligação com o uso do medicamento é considerada suspeita, recomendando-se acompanhamento clínico para avaliar a evolução dos sintomas.

O medicamento Benlysta, cujo princípio ativo é o belimumabe, foi associado a febre, interpretada como possível manifestação de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade significativa nem detalhes sobre o desfecho, sendo a relação com o medicamento considerada suspeita; é indicado observar a evolução clínica e procurar orientação médica se necessário.

O medicamento Loratadina, com princípio ativo loratadina, foi relacionado a um episódio de choque anafilático, que é uma reação alérgica grave e potencialmente fatal caracterizada por queda de pressão, dificuldade para respirar e risco de morte. Apesar de o registro não indicar gravidade elevada, o tipo de reação descrita exige atenção imediata e tratamento de emergência, sendo fundamental buscar atendimento médico urgente diante de sintomas compatíveis.

O medicamento Berotec, cujo princípio ativo é o fenoterol hidrobrometo, foi associado a um caso de choque anafilático, uma reação alérgica grave que pode causar risco à vida, com sintomas como falta de ar intensa, queda de pressão e necessidade de intervenção médica urgente. Embora o registro não detalhe a gravidade ou o desfecho, a natureza da reação exige atenção imediata e tratamento emergencial.

O medicamento Iodo, cujo princípio ativo é Iodine, foi associado a um episódio de choque anafilático, caracterizado como uma reação de hipersensibilidade (alergia grave) envolvendo o sistema imunológico. Embora a gravidade não tenha sido explicitamente informada, o termo 'choque anafilático' indica uma reação potencialmente grave e de rápida evolução, exigindo atenção médica imediata. O desfecho do caso é desconhecido, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita.

O ácido acetilsalicílico (princípio ativo: Acetylsalicylic acid), também conhecido como aspirina, foi relacionado a um caso de choque anafilático, uma reação alérgica aguda e potencialmente grave do sistema imunológico. Apesar de a gravidade não estar detalhada, o quadro de choque anafilático sugere risco elevado e necessidade de intervenção médica urgente. O desfecho permanece desconhecido e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Skyrizi, cujo princípio ativo é Risankizumab, foi associado a um episódio de choque anafilático, uma reação alérgica grave do sistema imunológico. Não há detalhamento sobre a gravidade no registro, mas o termo 'choque anafilático' indica uma situação clínica de risco que requer atendimento imediato. O desfecho do caso não foi informado e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Cilinon, com princípio ativo Ampicillin sodium, foi relacionado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), envolvendo o sistema imunológico e classificado como clinicamente significativo. O registro indica que a reação foi considerada grave, mas o paciente se recuperou totalmente após a conduta adequada. A relação com o medicamento foi considerada suspeita.

O medicamento Optiray, cujo princípio ativo é Ioversol, foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), envolvendo o sistema imunológico. Não há detalhamento sobre a gravidade, mas o caso evoluiu para recuperação completa após a reação, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita.

O medicamento Perjeta her, que contém os princípios ativos Pertuzumab e Trastuzumab, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como um distúrbio do sistema imunitário. Neste caso, a reação foi considerada grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que indica um evento clínico relevante que exige acompanhamento médico rigoroso. O desfecho da reação não foi informado, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

A Doxorubicina (Doxorubicin hydrochloride) foi relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, pois não houve indicação de hospitalização ou complicações maiores, e o paciente se recuperou totalmente após a reação. A relação com o medicamento é suspeita.

O uso de Fluoresceína (Fluorescein sodium) resultou em uma alergia a contraste intravenoso, que é uma reação do sistema imunitário a substâncias químicas utilizadas em exames. O quadro não foi considerado grave, já que não houve necessidade de hospitalização ou complicações, e o paciente se recuperou completamente. A relação com o medicamento é suspeita.

A administração de Fluoresceína (Fluorescein sodium) também foi associada a uma alergia a contraste intravenoso, caracterizada como uma reação do sistema imunitário. Assim como no caso anterior, a reação não foi grave e o paciente se recuperou sem intercorrências, sendo a relação com o medicamento considerada suspeita.

O medicamento Henetix, composto por Sodium calcium edetate, Trometamol, lobitridol e Trometamol hydrochloride, foi relacionado ao surgimento de prurido (coceira), um quadro de hipersensibilidade do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave, pois não houve necessidade de hospitalização ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente. A relação com o medicamento é suspeita.

O medicamento Puran t4, cujo princípio ativo é Levothyroxine sodium, foi associado a um quadro de coceira, caracterizando uma reação de hipersensibilidade (alergia) do tipo imunológica. A gravidade foi considerada clinicamente significativa, pois o registro indica que o evento foi classificado como outro efeito clinicamente relevante e grave, embora o paciente tenha se recuperado totalmente após a reação. Em situações como essa, é fundamental interromper o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas terapêuticas.

O Ferinject, que contém Ferric Carboxymaltose como princípio ativo, desencadeou um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, relacionado a distúrbios do sistema imunitário. Apesar de não ter sido considerado grave, o paciente se recuperou completamente após o evento. Nesses casos, recomenda-se suspender o uso do medicamento e procurar orientação médica para avaliação da necessidade de alternativas e prevenção de novas exposições.

O Tylenol, cujo princípio ativo é Paracetamol, foi relacionado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, envolvendo o sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o paciente evoluiu para recuperação total. Diante de reações alérgicas a analgésicos comuns, é importante evitar novas exposições e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre opções seguras.

A Fenitoína (Phenytoin) foi associada a um episódio de alergia, caracterizado como hipersensibilidade imunológica, sem gravidade significativa e com desfecho favorável, já que o paciente se recuperou. Em casos de alergia a anticonvulsivantes, recomenda-se suspender o medicamento suspeito e consultar o médico para ajuste do tratamento e prevenção de recorrências.

O Montelair, que tem como princípio ativo o Montelukast sodium, foi relacionado a um distúrbio vascular descrito como evento adverso de hipersensibilidade, envolvendo o sistema imunológico. Não há informações suficientes sobre gravidade ou desfecho, portanto, é fundamental que o paciente seja avaliado por um médico para investigação detalhada, confirmação diagnóstica e definição da conduta adequada.

O medicamento Rivotril (princípio ativo: Clonazepam) foi associado a um distúrbio da tireoide, descrito como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta do sistema imunológico ao medicamento. Não há indicação de gravidade elevada, pois não há relato de desfecho grave ou complicações, e o desfecho permanece desconhecido. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, sendo importante monitorar sintomas e buscar avaliação médica para confirmação e conduta adequada.

O medicamento Fluoxetine (princípio ativo: Fluoxetine) foi relacionado a um distúrbio da tireoide, caracterizado como hipersensibilidade medicamentosa, o que significa uma possível reação alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Não há evidências de gravidade significativa, já que não foi relatado desfecho grave ou complicações, e o desfecho é desconhecido. A relação entre o uso do medicamento e a reação é considerada suspeita, sendo recomendada a observação dos sintomas e avaliação médica para esclarecimento e orientação.

O medicamento Actemra (princípio ativo: Tocilizumab) foi associado a um distúrbio da tireoide, classificado como hipersensibilidade medicamentosa, indicando uma possível reação alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Não há sinais de gravidade importante, pois não foi relatado desfecho grave e o resultado permanece desconhecido. A relação entre o uso do medicamento e a reação é considerada suspeita, sendo fundamental acompanhamento médico para avaliação e definição da conduta.

O medicamento Buscopan (princípio ativo: Hyoscine butylbromide) foi relacionado a um quadro de alergia, descrito como hipersensibilidade, ou seja, uma reação do sistema imunológico ao medicamento. Não há indicação de gravidade elevada, pois não houve relato de complicações graves e o desfecho foi de recuperação completa. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, e a conduta adequada inclui a suspensão do medicamento e acompanhamento médico, especialmente se houver recorrência dos sintomas.

O medicamento Benlysta (princípio ativo: Belimumab) foi associado a um episódio de surdez aguda, classificado como hipersensibilidade medicamentosa, sugerindo uma possível reação imunológica ao medicamento. Não há evidências de gravidade crítica, já que não foi relatado desfecho grave e o paciente se recuperou totalmente. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, sendo importante manter acompanhamento médico para monitoramento e prevenção de novos episódios.

O medicamento Piqray (Alpelisib) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, que é uma reação alérgica do sistema imunológico, descrita como relacionada a câncer ósseo neste caso. Não há indicação de gravidade elevada, pois o evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente. A conduta recomendada em situações de hipersensibilidade é a suspensão do medicamento e acompanhamento clínico, com encaminhamento ao especialista se necessário.

O medicamento Xolair (Omalizumab) foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, que é uma reação alérgica, tendo como evento associado a catarata. Não há evidência de gravidade significativa, pois o evento não foi classificado como grave e o desfecho permanece desconhecido. Em casos de hipersensibilidade, recomenda-se monitoramento e avaliação médica para definir a necessidade de ajuste ou suspensão do tratamento.

A Benzilpenicilina (Benzylpenicillin) foi associada a uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma alergia, sem detalhamento de sintomas específicos. O evento não foi considerado grave e o desfecho não foi informado. Em situações de alergia a antibióticos, é fundamental interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Xolair (Omalizumab) foi relacionado a um episódio de desmaio, classificado como alergia a alimentos, embora o contexto sugira uma reação alérgica sistêmica. Não há indicação de gravidade elevada, pois o evento não foi considerado grave e o desfecho é desconhecido. Em casos de reações alérgicas com sintomas sistêmicos como desmaio, recomenda-se avaliação médica imediata para investigação e manejo adequado.



O medicamento Ciprofloxacino (Ciprofloxacin hydrochloride) foi associado a uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma alergia, considerada clinicamente significativa e classificada como grave. Não há informações sobre o desfecho do caso. Diante de uma reação alérgica grave a antibióticos, a conduta recomendada é a suspensão imediata do medicamento e busca urgente por atendimento médico especializado para manejo da reação e prevenção de complicações.

O medicamento Qlaira, que contém os princípios ativos dienogest e estradiol valerato, foi associado a um caso de diabetes mellitus neonatal, um quadro raro em recém-nascidos caracterizado por aumento dos níveis de açúcar no sangue logo após o nascimento. Embora a gravidade não tenha sido especificada no registro, não há indicação de desfecho grave ou fatal, e o desfecho permanece desconhecido. A relação entre o uso do medicamento e o evento foi considerada suspeita, sendo importante monitorar e relatar qualquer alteração glicêmica em gestantes que utilizam este contraceptivo, especialmente em casos de histórico de alergias múltiplas.

A cortisona, cujo princípio ativo é a cortisone, foi relacionada a um caso de câncer de mama em paciente com histórico de alergia a picada de artrópode. Não há detalhes sobre a gravidade do evento ou o desfecho, e o caso foi considerado não grave, com a relação entre o medicamento e o câncer classificada como suspeita. É importante ressaltar que, até o momento, não existe evidência clínica direta que relacione o uso de cortisona ao desenvolvimento de câncer de mama, sendo necessária avaliação médica individualizada e acompanhamento regular.

O metotrexato, cujo princípio ativo é methotrexate, foi associado a um relato de câncer de mama em paciente com alergia a picada de artrópode. O registro não indica gravidade elevada nem desfecho conhecido, e a relação entre o medicamento e o evento foi considerada suspeita. Embora o metotrexato seja utilizado em diversas condições autoimunes e oncológicas, não há evidência clínica clara de que ele cause câncer de mama, sendo fundamental acompanhamento médico e investigação detalhada em casos suspeitos.

O medicamento Actemra, que tem como princípio ativo o tocilizumabe, foi relacionado a um caso de câncer de mama em paciente com alergia a picada de artrópode. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, e o evento foi considerado não grave, com suspeita de relação com o uso do medicamento. O tocilizumabe é utilizado para tratar doenças autoimunes e, até o momento, não há comprovação de que cause câncer de mama, sendo recomendada avaliação médica contínua para monitoramento de possíveis eventos adversos.

O medicamento Travatan, cujo princípio ativo é travoprost, foi associado a um caso de câncer da boca em paciente com alergia a picada de artrópode. O registro não indica gravidade significativa nem desfecho conhecido, e a relação entre o uso do medicamento e o evento foi considerada suspeita. Travatan é utilizado principalmente no tratamento do glaucoma, e não há evidência clínica estabelecida de que provoque câncer bucal, sendo importante manter acompanhamento médico e relatar qualquer sintoma incomum durante o uso.

O medicamento Cyclosporine, cujo princípio ativo é Ciclosporin, foi associado ao desenvolvimento de angioedema, uma reação de hipersensibilidade caracterizada por inchaço súbito em regiões como face, lábios ou vias aéreas. Embora o registro não traga detalhes sobre gravidade clínica, não há indicação de gravidade elevada e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento, sugerindo necessidade de acompanhamento médico para monitoramento e manejo adequado da reação.

O Xolair, que tem como princípio ativo o Omalizumab, foi relacionado ao surgimento de angioedema, um quadro de hipersensibilidade que pode causar inchaço em áreas como rosto e garganta. Não há menção de gravidade importante no registro e o caso segue sem resolução até o momento, sendo fundamental manter acompanhamento clínico para avaliar a evolução e necessidade de intervenções.

O medicamento Xolair (Omalizumab) apresentou novamente relato de angioedema, caracterizado por inchaço súbito decorrente de reação alérgica. Não há evidências de gravidade significativa e o desfecho permanece em andamento, reforçando a importância de observação clínica contínua para garantir segurança do paciente.

A Teicoplanina, cujo princípio ativo é Teicoplanin, foi associada a um quadro de alergia, entendido como reação de hipersensibilidade do sistema imunológico. O registro não especifica gravidade, desfecho ou conduta adotada, sendo importante que o paciente seja avaliado por profissional de saúde para confirmação diagnóstica e definição do melhor manejo.

O medicamento Flagass, que contém Simeticone, foi relacionado ao aparecimento de sangue nas fezes, evento descrito como possível manifestação de alergia alimentar (alergia ao leite). Não há indicação de gravidade elevada e o desfecho é desconhecido, sendo recomendada avaliação médica para investigação da causa e orientação sobre condutas apropriadas.

O medicamento Mylicon, cujo princípio ativo é o simeticone, foi associado ao aparecimento de sangue nas fezes, um sintoma que pode indicar uma reação alérgica alimentar, como alergia ao leite, conforme sugerido pela classificação clínica de distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade aumentada ou desfecho grave neste caso, e o desfecho permanece desconhecido, sendo importante considerar avaliação médica para investigação da causa e acompanhamento da evolução do quadro.

A vitamina D, com princípio ativo colecalciferol, foi relacionada ao surgimento de sangue nas fezes, o que pode estar ligado a uma reação alérgica alimentar, como alergia ao leite, dentro do contexto de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave, e o desfecho é desconhecido, recomendando-se acompanhamento clínico para esclarecimento da causa e monitoramento dos sintomas.

O medicamento Cerazette, que contém desogestrel como princípio ativo, foi associado ao sintoma de sangue nas fezes, sugerindo possível reação alérgica alimentar, como alergia ao leite, enquadrada em distúrbios do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade aumentada ou desfecho grave, e o desfecho permanece desconhecido, sendo indicada avaliação médica para investigação e seguimento do quadro.

O medicamento Methotrexate, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado ao desenvolvimento de vasculite, uma inflamação dos vasos sanguíneos que pode ocorrer como manifestação de hipersensibilidade, dentro do grupo de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade aumentada ou desfecho grave, e o paciente evoluiu para recuperação completa, indicando resolução do evento adverso após conduta apropriada.

O medicamento Reuquinol, cujo princípio ativo é o sulfato de hidroxycloquina, foi associado ao surgimento de vasculite, uma inflamação dos vasos sanguíneos que pode ser manifestação de hipersensibilidade, classificada entre quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há indícios de gravidade aumentada ou desfecho grave, e o paciente apresentou recuperação completa, sugerindo resolução do quadro após as medidas adotadas.

O medicamento Azathioprine, cujo princípio ativo é azathioprine sodium, foi associado a um quadro de vasculite, que é uma reação de hipersensibilidade caracterizada por inflamação dos vasos sanguíneos. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi resolvido com recuperação completa, e não há menção de complicações graves. A conduta recomendada em situações de hipersensibilidade é a suspensão do medicamento e acompanhamento médico para evitar recorrências, sendo importante relatar o episódio ao especialista para avaliação de alternativas terapêuticas.

O medicamento Benlysta, cujo princípio ativo é belimumab, foi relacionado a um episódio de vasculite, que consiste em uma reação alérgica (hipersensibilidade) envolvendo inflamação dos vasos sanguíneos. O caso não foi considerado grave, pois houve resolução completa do quadro, sem evolução para complicações. Em situações como essa, recomenda-se interromper o uso do medicamento e buscar orientação médica para monitoramento e definição do tratamento mais seguro.

A azitromicina, cujo princípio ativo é azithromycin, foi associada a comprometimento das atividades da vida diária devido a uma reação de hipersensibilidade, que pode se manifestar por sintomas alérgicos gerais. Não há informações sobre gravidade aumentada ou desfecho final, mas a limitação das atividades sugere impacto moderado. Nesses casos, é importante interromper o uso do medicamento e procurar avaliação médica para manejo dos sintomas e prevenção de novas reações.

O medicamento identificado apenas como cálcio, com princípio ativo calcium phosphate, foi relacionado a comprometimento das atividades da vida diária por reação de hipersensibilidade, indicando sintomas alérgicos que interferiram na rotina do paciente. Não há detalhes sobre gravidade ou desfecho, mas a restrição funcional sugere necessidade de avaliação médica para ajuste do tratamento e investigação de alternativas seguras.

A sinvastatina, cujo princípio ativo é simvastatin, foi associada a uma reação de hipersensibilidade que comprometeu as atividades da vida diária, indicando sintomas alérgicos que afetaram o cotidiano do paciente. Não há informações sobre gravidade elevada ou desfecho, mas a limitação funcional reforça a importância de interromper o uso do medicamento e buscar orientação médica para avaliação e definição de conduta adequada.

O medicamento Atrovent, cujo princípio ativo é o brometo de ipratrópio, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), manifestando-se por sintomas que comprometeram as atividades da vida diária. A reação foi classificada como relacionada a distúrbios do sistema imunitário, especificamente quadros clínicos alérgicos, mas não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, sugerindo um evento de intensidade leve a moderada, conforme o contexto clínico da ASBAI para reações alérgicas respiratórias. Recomenda-se acompanhamento clínico para confirmação diagnóstica e orientação sobre controle ambiental e identificação de gatilhos.

O medicamento Berotec, com princípio ativo fenoterol hidrobrometo, apresentou relato de hipersensibilidade (alergia), levando a prejuízo nas atividades cotidianas. A reação foi enquadrada como distúrbio do sistema imunitário, dentro do espectro de quadros clínicos alérgicos, sem sinais de gravidade importante ou desfecho informado, o que sugere um evento leve a moderado. A conduta recomendada é observação clínica, redução de exposição a possíveis gatilhos e avaliação médica para confirmação e manejo adequado.

O medicamento Spiriva, cujo princípio ativo é o brometo de tiotrópio, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), com impacto nas atividades diárias do paciente. O quadro foi classificado como distúrbio do sistema imunitário, especificamente quadros clínicos alérgicos, sem evidências de gravidade significativa ou desfecho relatado, indicando uma reação de intensidade leve a moderada. Recomenda-se avaliação clínica estruturada para confirmação diagnóstica e orientação sobre controle ambiental e identificação de fatores desencadeantes.

O medicamento Alenia, com princípio ativo esomeprazol magnésio, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), resultando em comprometimento das atividades diárias. A reação foi categorizada como distúrbio do sistema imunitário, dentro dos quadros clínicos alérgicos, sem indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, sugerindo um evento leve a moderado. A recomendação é buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre manejo e prevenção de novas reações.

O medicamento Predsim, cujo princípio ativo é o fosfato sódico de prednisolona, apresentou relato de hipersensibilidade (alergia), com prejuízo nas atividades do dia a dia. O evento foi classificado como distúrbio do sistema imunitário, especificamente quadros clínicos alérgicos, sem sinais de gravidade importante ou desfecho informado, caracterizando uma reação leve a moderada. Recomenda-se acompanhamento clínico para confirmação diagnóstica e definição do melhor plano de controle.

O medicamento Nucala, cujo princípio ativo é o mepolizumabe, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), manifestado por comprometimento das atividades da vida diária. Embora não haja indicação de gravidade elevada ou necessidade de hospitalização, a reação sugere envolvimento do sistema imunológico, sendo

importante monitorar sintomas e buscar orientação médica para ajuste do tratamento, especialmente se houver piora clínica.

A Hypocina composta, que contém hioscina butilbrometo e metamizol sódico monoidratado, foi relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), caracterizado por manifestação imunológica sem gravidade significativa, já que o paciente encontra-se em recuperação ou resolução do quadro. Recomenda-se evitar nova exposição ao medicamento e acompanhamento médico para garantir completa recuperação.

O medicamento Neovlar, composto por etinilestradiol e levonorgestrel, foi associado a uma recidiva de esclerose múltipla, considerada uma reação de hipersensibilidade com gravidade relevante, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação. O paciente evoluiu para recuperação ou resolução do quadro, sendo fundamental acompanhamento médico rigoroso e avaliação criteriosa do uso futuro deste medicamento.

O Microvlar, que também contém etinilestradiol e levonorgestrel, esteve relacionado a uma recidiva de esclerose múltipla, caracterizada como reação de hipersensibilidade e considerada grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação. O desfecho foi favorável, com recuperação ou resolução, mas é essencial manter acompanhamento médico e reavaliar a indicação do medicamento.

O Diclin, cujo princípio ativo é o diclofenaco sódico, foi associado a uma recidiva de esclerose múltipla, configurando uma reação de hipersensibilidade classificada como grave, pois exigiu hospitalização ou prolongamento da internação. O paciente se recuperou ou teve resolução do quadro, sendo importante discutir alternativas terapêuticas e manter vigilância médica em futuras prescrições.

O medicamento Vitamin D, cujo princípio ativo é Vitamin D NOS, foi associado a um episódio de recidiva de esclerose múltipla, caracterizado como uma reação de hipersensibilidade (alergia), enquadrada em quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. O evento foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando a necessidade de acompanhamento médico rigoroso. O paciente evoluiu para recuperação completa após a conduta hospitalar adequada.

O medicamento Vitamin D, com princípio ativo Vitamin D NOS, esteve relacionado a uma recidiva de esclerose múltipla, interpretada como reação de hipersensibilidade (alergia), dentro do contexto de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. A gravidade do caso é confirmada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que reforça a importância de monitoramento médico. O desfecho foi favorável, com recuperação total do paciente.

O medicamento Femiane, composto por etinilestradiol e gestodeno, foi implicado em um episódio de recidiva de esclerose múltipla, classificado como reação de hipersensibilidade (alergia), pertencente ao grupo de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. O evento foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando a importância de avaliação médica imediata. O paciente apresentou recuperação completa após o manejo clínico.

O medicamento Propramed, cujo princípio ativo é propranolol hydrochloride, esteve associado a uma recidiva de esclerose múltipla, interpretada como reação de hipersensibilidade (alergia), enquadrada em quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. O caso foi considerado grave, pois exigiu hospitalização ou prolongamento da internação, ressaltando a necessidade de acompanhamento médico. O paciente se recuperou totalmente após a intervenção adequada.

O medicamento Rebif, com princípio ativo interferon beta-1a, foi relacionado a uma recidiva de esclerose múltipla, caracterizada como reação de hipersensibilidade (alergia), dentro do contexto de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. A gravidade do evento é evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que reforça a importância de monitoramento especializado. O paciente evoluiu para recuperação completa após o tratamento.

O medicamento Avonex, cujo princípio ativo é o interferon beta-1a, foi associado a um episódio de recidiva de esclerose múltipla, interpretado como uma reação de hipersensibilidade (alergia) do tipo imunológica. O caso foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando a necessidade de acompanhamento médico rigoroso. Apesar da gravidade, o paciente se recuperou totalmente após a conduta clínica adequada.

O Avonex, contendo interferon beta-1a, esteve relacionado a uma recidiva de esclerose múltipla atribuída a hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico. A gravidade foi confirmada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que reforça a importância de monitoramento especializado. O desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente após as medidas adotadas.

O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é o tozinameran, foi relacionado a um caso de uveíte, interpretado como uma manifestação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. Não há informação sobre gravidade clínica relevante ou necessidade de hospitalização, e o desfecho permanece desconhecido, sendo importante o acompanhamento médico para esclarecimento da evolução.

O Docetaxel, tanto nome comercial quanto princípio ativo, foi associado a um quadro de alergia classificado como hipersensibilidade, envolvendo o sistema imunológico. Não houve indicação de gravidade clínica significativa, como hospitalização, e o paciente se recuperou totalmente após a conduta médica apropriada.

O medicamento B platin, cujo princípio ativo é o carboplatina, esteve envolvido em um episódio de alergia (hipersensibilidade) que exigiu hospitalização ou prolongamento da internação, caracterizando um evento grave. Apesar da gravidade, o paciente se recuperou, porém com sequelas, ressaltando a importância do manejo especializado em reações alérgicas a quimioterápicos.

O medicamento Tramadol, cujo princípio ativo também é tramadol, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do sistema imunológico. Não há descrição de sintomas específicos ou gravidade aumentada, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A ausência de complicações e o desfecho favorável sugerem que a reação foi leve, não havendo necessidade de intervenções além da suspensão do medicamento e acompanhamento clínico.

A Dipirona, cujo princípio ativo é metamizol sódico, foi relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), envolvendo resposta do sistema imunológico. Não foram relatados sintomas graves ou complicações, e o paciente evoluiu para recuperação completa. Esses dados indicam que a reação foi leve, sendo suficiente a interrupção do uso do medicamento e observação clínica, sem necessidade de medidas adicionais.

O medicamento Dramin, com princípio ativo dimenidrinato, esteve associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade), manifestada como resposta imunológica adversa. Não há relato de sintomas graves ou evolução desfavorável, e o paciente se recuperou totalmente. Isso sugere que a reação foi leve, resolvida com a suspensão do medicamento e acompanhamento médico, sem necessidade de intervenções emergenciais.

A Nalbufina, cujo princípio ativo é cloridrato de nalbufina, foi relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), envolvendo ativação do sistema imunológico. Não há descrição de sintomas graves ou complicações, e o paciente apresentou recuperação completa após o evento. Esses achados indicam que a reação foi leve, sendo suficiente a suspensão do medicamento e monitoramento clínico.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é iopromida, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade), caracterizada por resposta do sistema imunológico. Não houve gravidade aumentada, conforme informado, e o paciente se recuperou totalmente. Isso indica que a reação foi leve, resolvida com a suspensão do agente e acompanhamento clínico, sem necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Insulina humana (princípio ativo: Insulin human) foi associado a um quadro de alergia, caracterizado como hipersensibilidade, que se enquadra nos distúrbios do sistema imunitário. Não há informações detalhadas sobre a gravidade ou desfecho do caso, portanto, recomenda-se atenção clínica para sinais de reações alérgicas, com avaliação médica estruturada para confirmação diagnóstica e definição do manejo, conforme orientações da ASBAI.

O medicamento Budesonide (princípio ativo: Budesonide) foi relacionado a um caso de hipertensão pulmonar, descrito como uma manifestação de hipersensibilidade dentro dos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento, sugerindo a necessidade de acompanhamento médico para monitoramento da evolução e ajuste do tratamento, conforme a conduta recomendada para quadros moderados pela ASBAI.

O medicamento Prednisone (princípio ativo: Prednisone) apresentou associação com hipertensão pulmonar, interpretada como uma reação de hipersensibilidade relacionada ao sistema imunitário. O caso não foi classificado como grave e ainda não houve resolução, indicando que o paciente deve ser acompanhado clinicamente para avaliação contínua e possível ajuste terapêutico, seguindo as recomendações para reações moderadas.

O medicamento Carvedilol (princípio ativo: Carvedilol) foi implicado em um episódio de hipertensão pulmonar, considerado uma manifestação de hipersensibilidade do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e permanece sem resolução, sendo importante manter o acompanhamento médico para monitorar a evolução e reavaliar a conduta, conforme orientações para casos moderados.

O medicamento Xolair (princípio ativo: Omalizumab) esteve associado a um caso de hipertensão pulmonar, descrito como reação de hipersensibilidade do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o desfecho segue não resolvido, recomendando-se acompanhamento clínico regular para monitoramento e ajuste do tratamento, conforme as diretrizes para quadros moderados.

O medicamento Piqray, cujo princípio ativo é o Alpelisib, foi associado ao aumento da glicemia, sendo classificado como um quadro de hipersensibilidade (alergia) relacionado a distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A reação relatada sugere um evento leve, sem evidências de complicações graves, e recomenda-se acompanhamento clínico para monitoramento e esclarecimento diagnóstico, conforme diretrizes da ASBAI.

O medicamento Rivotril, com princípio ativo Clonazepam, foi relacionado ao surgimento de hemorroidas em um contexto de alergia a alimentos, classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade significativa ou desfecho, e a relação com o medicamento é suspeita. A descrição sugere um evento leve, sem sinais de gravidade clínica, sendo importante avaliar outras causas e considerar acompanhamento médico para investigação adequada.

O medicamento Olcadil, cujo princípio ativo é Cloxazolam, foi associado ao aparecimento de hemorroidas em um contexto de alergia a alimentos, enquadrando-se em distúrbios do sistema imunitário. Não há dados que indiquem gravidade ou desfecho, e a relação com o medicamento é suspeita. O quadro descrito sugere uma reação leve, sem evidências de complicações, sendo recomendada avaliação clínica para confirmação diagnóstica e orientação adequada.

O medicamento Proctyl, composto por Cinchocaine hydrochloride e Policresulen, foi relacionado ao desenvolvimento de hemorroidas em um contexto de alergia a alimentos, classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, e a relação com o medicamento é suspeita. O evento relatado sugere uma reação leve, sem sinais de gravidade, sendo importante buscar avaliação médica para esclarecimento e conduta apropriada.

O medicamento Proctyl, contendo Cinchocaine hydrochloride e Policresulen, foi associado ao surgimento de hemorroidas em um contexto de alergia a alimentos, dentro da categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade ou desfecho informado, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. O quadro sugere uma reação leve, recomendando-se avaliação clínica para investigação e orientação conforme necessidade.

O medicamento Irinotecano (princípio ativo: Irinotecan hydrochloride) foi associado a um quadro de alergia medicamentosa, tecnicamente descrito como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. A reação foi considerada clinicamente significativa, pois foi classificada como outro efeito clinicamente relevante e marcada como grave, o que indica a necessidade de atenção médica imediata e acompanhamento rigoroso. O desfecho informado foi de recuperação completa do paciente após a reação, sugerindo resolução do quadro após as medidas adotadas.

O medicamento Benzilpenicilina benzatina (princípio ativo: Benzathine benzylpenicillin) foi relacionado a um episódio de alergia, tecnicamente chamado de hipersensibilidade, dentro do grupo de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade aumentada ou complicações relevantes, e não foram fornecidos detalhes sobre o desfecho ou conduta, sugerindo que o quadro foi leve e sem maiores consequências clínicas.

O medicamento Tramadol (princípio ativo: Tramadol hydrochloride) esteve associado a uma reação alérgica, descrita tecnicamente como hipersensibilidade, pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. Não há menção de gravidade aumentada ou complicações, nem detalhes sobre o desfecho, o que sugere um quadro leve e sem evolução clínica preocupante.

O medicamento Cloridrato de ondansetrona (princípio ativo: Ondansetron hydrochloride) foi relacionado a um episódio de alergia, tecnicamente denominado hipersensibilidade, dentro da categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há registro de gravidade aumentada ou complicações, nem informações sobre o desfecho, indicando que a reação foi provavelmente leve e sem maiores repercussões clínicas.

O medicamento Loratadina (princípio ativo: Loratadine) foi associado a uma reação alérgica, tecnicamente chamada de hipersensibilidade, pertencente ao grupo de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade aumentada ou complicações, nem detalhes sobre o desfecho, sugerindo que o quadro foi leve e sem evolução clínica relevante.

O medicamento Hidrocortisona, cujo princípio ativo é Hydrocortisone butyrate, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, que se enquadra nos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade significativa ou desfecho grave neste caso, sugerindo uma reação leve, compatível com quadros clínicos alérgicos comuns. A conduta recomendada é observar os sintomas, evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

A Prometazina, com princípio ativo Promethazine hydrochloride, foi relacionada a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade ou complicações graves, indicando um quadro leve de alergia. Recomenda-se suspender o uso do medicamento, monitorar os sintomas e procurar orientação médica para avaliação e definição de tratamento adequado.

O Paracetamol, cujo princípio ativo é o próprio Paracetamol, foi associado a uma reação de hipersensibilidade, caracterizada como alergia leve e relacionada a distúrbios do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade ou desfecho grave, sugerindo que a reação foi limitada. A recomendação é evitar o uso futuro do medicamento, observar possíveis sintomas e buscar avaliação médica para confirmação e orientação sobre alternativas.

O Omeprazol, com princípio ativo Omeprazole, foi relacionado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), classificado como clinicamente significativo e grave, mas com desfecho de recuperação completa. A reação envolveu distúrbios do sistema imunitário e exigiu atenção médica, sendo

importante evitar nova exposição ao medicamento e manter acompanhamento para prevenção de recorrências.

A Cefalexina, cujo princípio ativo é Cefalexin, foi associada a uma alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), considerada clinicamente significativa e grave, porém com resolução completa do quadro. O evento envolveu distúrbios do sistema imunitário e demandou suspensão do medicamento e acompanhamento médico, sendo fundamental evitar reexposição e informar profissionais de saúde sobre o histórico de alergia.

O medicamento Levotiroxina (princípio ativo: Levothyroxine) foi associado a um quadro de alergia medicamentosa, também chamada de hipersensibilidade medicamentosa, que se enquadra nos distúrbios do sistema imunitário. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, conforme evidenciado pela classificação do evento, mas o paciente evoluiu para recuperação completa após a conduta adequada. O caso foi relacionado de forma suspeita ao uso do medicamento, reforçando a importância de acompanhamento médico e avaliação criteriosa em situações de alergia a medicamentos.

A Fentanila (princípio ativo: Fentanyl citrate) esteve envolvida em um episódio de alergia medicamentosa, tecnicamente denominada hipersensibilidade medicamentosa, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. O evento foi considerado grave devido ao seu impacto clínico relevante, mas o paciente se recuperou totalmente após as medidas necessárias. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, destacando a necessidade de atenção médica imediata diante de sinais de alergia a medicamentos.

O medicamento Metaminol (princípio ativo: Metaminol tartrate) foi associado a uma reação de alergia medicamentosa, também chamada de hipersensibilidade medicamentosa, classificada como distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, mas o paciente apresentou recuperação completa após a conduta apropriada. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, ressaltando a importância de monitoramento e avaliação médica em casos de alergia a medicamentos.

A Neocaina pesada, composta pelos princípios ativos Bupivacaine hydrochloride e Glucose, esteve relacionada a um episódio de alergia medicamentosa, tecnicamente chamada de hipersensibilidade medicamentosa, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. O evento foi classificado como grave devido à sua relevância clínica, mas o paciente se recuperou totalmente após as medidas adequadas. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, indicando a necessidade de acompanhamento médico rigoroso em situações de alergia a anestésicos.

A Ocitocina (princípio ativo: Oxytocin) foi associada a um caso de alergia medicamentosa, também conhecida como hipersensibilidade medicamentosa, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, mas o paciente evoluiu para recuperação completa após a conduta adequada. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, reforçando a importância de avaliação médica imediata diante de sinais de alergia a medicamentos.

O medicamento Simeticona, cujo princípio ativo é Simeticone, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado como um distúrbio do sistema imunitário. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, conforme registrado, mas o paciente evoluiu para recuperação completa após a conduta adequada. A relação causal com o medicamento foi considerada suspeita, e a conduta seguiu o manejo padrão para reações alérgicas a medicamentos, com resolução do quadro.

A Dexametasona, identificada pelo princípio ativo Dexamethasone acetate, desencadeou uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. O evento foi classificado como clinicamente significativo e grave, com suspeita de relação causal com o medicamento, mas o paciente apresentou recuperação total após as medidas apropriadas. O caso ilustra a importância do reconhecimento e manejo imediato de reações alérgicas a medicamentos, mesmo em fármacos amplamente utilizados.



O medicamento Morfina, cujo princípio ativo é Morphine sulfate, foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, com suspeita de relação causal, mas o paciente se recuperou completamente após a intervenção adequada. Este caso reforça a necessidade de vigilância para reações alérgicas mesmo em analgésicos comuns.

O medicamento Tramal, com princípio ativo Tramadol hydrochloride, esteve envolvido em um caso de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), classificado como distúrbio do sistema imunitário. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, com suspeita de relação causal, e o paciente evoluiu para recuperação total após a conduta apropriada. O episódio destaca a importância do reconhecimento precoce e manejo de reações alérgicas a analgésicos.

O medicamento Lidocaina, cujo princípio ativo é Lidocaine, foi associado a uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, com suspeita de relação causal, mas o paciente apresentou recuperação completa após as medidas necessárias. O caso ressalta a necessidade de atenção a reações alérgicas mesmo em anestésicos locais de uso frequente.

O medicamento Artrínid, cujo princípio ativo é o ketoprofeno, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado como um distúrbio do sistema imunitário. A reação foi considerada clinicamente significativa, pois foi classificada como grave, mas o paciente evoluiu para recuperação completa após a conduta adequada. Em situações como essa, é fundamental suspender o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

A Dipirona, que tem como princípio ativo o metamizol sódico, desencadeou um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Embora não haja detalhamento sobre a gravidade, o paciente se recuperou totalmente após a reação. Nesses casos, recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e consultar um especialista para avaliação e orientação sobre alternativas.

O medicamento Cloridrato de ondansetrona, cujo princípio ativo é ondansetrona, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave e o paciente se recuperou completamente. Em situações assim, é importante suspender o uso do medicamento e informar o médico para avaliação e registro da reação, visando evitar novas exposições.

A Vancomicina, com princípio ativo vancomicina, foi associada a um quadro de taquicardia relacionado à hipersensibilidade, enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave e o paciente se recuperou. É importante relatar esse tipo de evento ao médico para avaliação da necessidade de ajuste terapêutico e prevenção de novas reações.

No caso da Ceftriaxona, com princípio ativo ceftriaxona, houve um erro de prescrição em paciente com hipersensibilidade documentada ao produto, o que representa um risco relevante de reação alérgica. Não há informações detalhadas sobre a evolução clínica ou gravidade, mas situações assim exigem imediata suspensão do medicamento e revisão criteriosa do histórico de alergias antes de novas prescrições, além de notificação do erro para prevenção de recorrências.

O medicamento Mesalazina (princípio ativo Mesalazine) foi associado a um quadro de tuberculose descrito como hipersensibilidade, classificado entre quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, pois o paciente foi recuperado ou resolvido após o evento, sugerindo que a reação foi controlada adequadamente. A relação do medicamento com o evento foi considerada suspeita, e a conduta adotada resultou em desfecho favorável.

O medicamento Humira (princípio ativo Adalimumabe) esteve relacionado a um episódio de tuberculose, descrito como hipersensibilidade e enquadrado em quadros clínicos alérgicos dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade significativa, já que o paciente se recuperou ou teve resolução do quadro, indicando que a reação foi manejada de forma eficaz. O evento foi considerado suspeito em relação ao uso do medicamento.

A Espironolactona (princípio ativo Spironolactone) foi associada a um caso de descolamento da retina, descrito como alergia sazonal e classificado entre distúrbios atópicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade aumentada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Não há detalhes suficientes para afirmar a conduta adotada ou a evolução clínica do paciente.

O medicamento Alenia, com princípio ativo Esomeprazole magnesium, foi relacionado a um episódio de descolamento da retina, descrito como alergia sazonal e incluído entre distúrbios atópicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade relevante nem informações sobre o desfecho, e a relação com o medicamento é suspeita. Não há dados suficientes para detalhar a conduta ou a evolução do caso.

O medicamento Sabutal (princípio ativo Salbutamol sulfate) foi associado a um caso de descolamento da retina, descrito como alergia sazonal e classificado entre distúrbios atópicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade aumentada nem informações sobre o desfecho, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Não há detalhes disponíveis sobre a conduta adotada ou a evolução clínica do paciente.

O medicamento Clonazepam (princípio ativo: Clonazepam) foi associado a um caso de descolamento da retina, um evento raro em que a camada sensível à luz do olho se separa da parte de trás do globo ocular, podendo causar perda de visão. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, pois não foram relatados sinais clínicos de gravidade nem desfecho conhecido, e o evento foi classificado como não grave. A relação entre o uso do medicamento e o evento foi considerada suspeita, mas não há informações sobre a conduta adotada ou evolução do quadro.

O medicamento Sinvastatina (princípio ativo: Simvastatin) foi relacionado a um episódio de descolamento da retina, que é uma condição ocular potencialmente séria, mas neste registro não há evidências clínicas de gravidade aumentada, pois o caso foi classificado como não grave e o desfecho permanece desconhecido. A suspeita de relação com o medicamento existe, mas não há detalhes sobre a conduta tomada ou evolução do paciente.

O medicamento Losartana potássica (princípio ativo: Losartan potassium) foi associado a um caso de descolamento da retina, que é a separação da retina do fundo do olho e pode comprometer a visão. Neste caso, não há sinais de gravidade aumentada, pois foi classificado como não grave e o desfecho não foi informado. A relação com o medicamento é considerada suspeita, mas não há dados sobre a conduta adotada ou evolução clínica.

O medicamento Berotec (princípio ativo: Fenoterol hydrobromide) foi relacionado a um caso de descolamento da retina, uma condição em que a retina se separa da parede do olho, podendo afetar a visão. O evento foi considerado não grave, sem informações sobre evolução ou conduta, e a relação com o medicamento é apenas suspeita, sem confirmação de causalidade.

O medicamento Atrovent (princípio ativo: Ipratropium bromide) foi associado a um episódio de descolamento da retina, que é uma alteração ocular importante, mas neste caso não foi classificada como grave e não há informações sobre o desfecho ou medidas tomadas. A relação com o medicamento é suspeita, mas não há dados adicionais que permitam avaliar a evolução clínica.

O medicamento Spiolto Respimat, que contém os princípios ativos olodaterol hydrochloride e tiotropium bromide monohydrate, foi associado a um caso de descolamento da retina, uma condição rara e grave que pode afetar a visão. Embora o registro não traga detalhes sobre a gravidade clínica ou o desfecho, a relação suspeita com o uso do medicamento exige atenção imediata e avaliação oftalmológica, especialmente porque não há confirmação de

gravidade nem informações sobre a evolução do quadro.

A Dipirona (princípio ativo metamizol sódico) foi relacionada a um episódio de alergia documentada ao medicamento administrado, caracterizando uma reação de hipersensibilidade. O caso não apresenta sinais de gravidade nem desfecho informado, mas a identificação prévia de alergia ao medicamento reforça a necessidade de evitar novas exposições e de registrar a reação no prontuário para prevenir riscos futuros.

O medicamento Etoposide, cujo princípio ativo é o etoposide phosphate, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade no registro e o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente, indicando que a reação foi controlada adequadamente.

O Levothyroxine sodium, tanto como nome comercial quanto princípio ativo, foi relacionado a um episódio de sangue nas fezes em um paciente com alergia ao leite, sugerindo possível reação alérgica alimentar. O caso não foi considerado grave e o paciente está em recuperação, indicando que a conduta adotada foi suficiente para controlar a situação até o momento.

A Novalgina, que tem como princípio ativo o metamizol sódico, foi associada a uma alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade e o paciente se recuperou totalmente, mostrando que a reação foi resolvida sem complicações.

O medicamento Ciprofloxacino, cujo princípio ativo é o ciprofloxacina hydrochloride, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há informação sobre gravidade clínica relevante ou desfecho do caso, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A ausência de dados sobre evolução e conduta impede detalhamento adicional, mas a suspeita de reação alérgica sugere a necessidade de avaliação médica para confirmação e orientação quanto à continuidade ou suspensão do uso.

A Oxacilina, com princípio ativo oxacillin, foi relacionada a um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhamento sobre gravidade, mas o desfecho foi de recuperação ou resolução do quadro, indicando que a reação foi controlada ou cessou após intervenção, sendo a relação com o medicamento considerada suspeita. A conduta adotada não foi especificada, mas a resolução sugere manejo clínico adequado.

O medicamento Cefepime, cujo princípio ativo é o próprio cefepime, foi associado a uma reação de alergia descrita como hipersensibilidade, enquadrada nos distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou conduta adotada, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Diante da suspeita de reação alérgica, recomenda-se avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição do manejo.

O Sodium chloride, identificado tanto como nome comercial quanto princípio ativo, foi relacionado a um episódio de alergia a contraste, classificado como clinicamente significativo e grave, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. O desfecho do caso é desconhecido, mas a gravidade relatada indica a necessidade de atenção médica imediata e manejo especializado, especialmente por se tratar de reação a contraste, que pode evoluir rapidamente e requer suporte adequado.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, foi associado a uma reação de alergia a contraste considerada clinicamente significativa e grave, pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. O desfecho não foi informado, mas a gravidade do evento sugere que o paciente necessitou de intervenção médica urgente, já que reações a contraste podem ser potencialmente perigosas e exigem monitoramento e tratamento imediato.

O medicamento Sodium chloride (princípio ativo: Sodium chloride) foi associado a um episódio de alergia a contraste, uma reação do sistema imunológico que pode ocorrer após a exposição a substâncias químicas usadas

em exames de imagem. Embora o nome comercial não tenha sido especificado, a gravidade foi considerada clinicamente significativa, indicando que a reação foi relevante do ponto de vista médico. O desfecho do caso não foi informado, e a relação entre o medicamento e a reação foi considerada suspeita, sendo importante monitorar e relatar eventos desse tipo para garantir a segurança do paciente.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é o Gadobutrol, foi relacionado a uma alergia a contraste, que é uma resposta do sistema imunológico após o uso de substâncias químicas em exames de imagem. Tanto o nome comercial quanto o princípio ativo estão claramente identificados. A reação foi classificada como clinicamente significativa, o que sugere que teve impacto relevante na saúde do paciente. O desfecho permanece desconhecido, e a relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, reforçando a necessidade de acompanhamento médico e notificação adequada.

O Sodium chloride (princípio ativo: Sodium chloride), sem nome comercial especificado, esteve envolvido em um caso de alergia a contraste, caracterizada por uma resposta imunológica adversa após exposição a substâncias químicas em exames médicos. A gravidade foi considerada clinicamente significativa, indicando que a reação teve importância médica. O desfecho não foi informado, e a relação com o medicamento é suspeita, sendo fundamental a observação clínica e o registro desse tipo de evento para aprimorar a segurança do paciente.

O medicamento Gadovist, com princípio ativo Gadobutrol, foi associado a uma alergia a contraste, uma reação do sistema imunológico que pode ocorrer após o uso de substâncias químicas em exames de imagem. Tanto o nome comercial quanto o princípio ativo estão presentes, e a gravidade foi considerada clinicamente significativa, sugerindo impacto relevante na saúde do paciente. O desfecho não foi informado, e a relação entre o medicamento e a reação é suspeita, sendo importante o acompanhamento médico e a notificação do evento.

O Sodium chloride (princípio ativo: Sodium chloride), sem nome comercial informado, esteve relacionado a um episódio de alergia a contraste, que é uma resposta imunológica adversa após a exposição a substâncias químicas usadas em exames de imagem. A reação foi considerada clinicamente significativa, indicando relevância médica, e o desfecho permanece desconhecido. A relação com o medicamento é suspeita, ressaltando a importância do monitoramento e da notificação desses eventos para a segurança do paciente.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, foi associado a um quadro de alergia a contraste, reação que envolve o sistema imunológico e pode se manifestar com sintomas como coceira, urticária, dificuldade para respirar ou outros sinais de hipersensibilidade após a administração do contraste. A gravidade do evento é considerada clinicamente significativa, pois foi classificada como grave, o que indica a necessidade de atenção médica imediata e possível intervenção para evitar complicações maiores. O desfecho do caso não foi informado, portanto não é possível afirmar se houve recuperação ou persistência dos sintomas.

O medicamento Sodium chloride (cloreto de sódio) foi relacionado a uma reação de alergia a contraste, mesmo sendo uma substância geralmente considerada segura; neste caso, a reação foi classificada como clinicamente significativa e grave, sugerindo que o paciente apresentou sintomas importantes de hipersensibilidade após o uso. Não há detalhes sobre a evolução do quadro, portanto não é possível informar se houve resolução ou persistência dos sintomas.

O Gadovist, com princípio ativo gadobutrol, foi novamente associado a um episódio de alergia a contraste, caracterizado por uma resposta do sistema imunológico após exposição ao agente, o que pode incluir sintomas como coceira, vermelhidão ou dificuldade respiratória. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, indicando a necessidade de avaliação médica imediata. O desfecho permanece desconhecido, não sendo possível afirmar se o paciente se recuperou.

O Sodium chloride (cloreto de sódio) foi relacionado a uma reação de alergia a contraste, considerada clinicamente significativa e grave, o que sugere que o paciente apresentou sintomas relevantes de hipersensibilidade após o uso do produto. Neste caso, o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente após a reação.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, foi associado a uma reação de alergia a contraste, caracterizada por resposta imunológica significativa após a administração do agente. O evento foi considerado grave e clinicamente relevante, exigindo atenção médica, mas o paciente evoluiu para recuperação completa após a reação.

O medicamento Tenoxicam (princípio ativo Tenoxicam) foi associado a um quadro de alergia, descrito como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. O evento foi considerado não grave, pois não há indicação de complicações clínicas importantes ou necessidade de hospitalização, e o paciente se recuperou totalmente após a reação. A conduta recomendada é evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Docetaxel (princípio ativo Docetaxel) desencadeou uma reação alérgica classificada como hipersensibilidade, relacionada a distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave, pois não houve relato de complicações sérias ou necessidade de internação, e o paciente evoluiu para recuperação completa. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e realizar acompanhamento com especialista para avaliação de alternativas terapêuticas.

A Bromoprida (princípio ativo Bromopride) foi associada a um episódio de alergia, caracterizado como hipersensibilidade e enquadrado nos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, já que não houve complicações clínicas relevantes e o paciente se recuperou totalmente. A orientação é suspender o uso do medicamento e procurar avaliação com alergista para confirmação da alergia e definição de opções seguras.

O medicamento Berotec, cujo princípio ativo é Fenoterol hydrobromide, foi relacionado a um quadro de dependência medicamentosa descrito como hipersensibilidade medicamentosa, dentro da categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade ou desfecho conhecido, mas é importante ressaltar que o uso frequente de broncodilatadores pode indicar descontrole da doença respiratória, sendo necessária reavaliação médica para ajuste do tratamento e prevenção de complicações.

O medicamento Zolpidem (princípio ativo Zolpidem) foi associado a convulsões, descritas como sensibilidade à borracha, dentro do contexto de alergias a medicamentos e distúrbios do sistema imunitário. O evento foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e outros efeitos clinicamente significativos, embora o desfecho não tenha sido informado. Diante de reações graves como convulsões, é fundamental interromper o uso do medicamento e buscar atendimento médico imediato para manejo adequado e investigação da causa.

O medicamento Velija, cujo princípio ativo é a duloxetina, foi associado a um episódio de convulsões em um paciente com sensibilidade à borracha, caracterizando uma reação alérgica relevante do tipo distúrbio do sistema imunitário. A gravidade do caso é sustentada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e por outros efeitos clinicamente significativos, indicando que se trata de uma reação grave. O desfecho da reação é desconhecido e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo fundamental acompanhamento médico rigoroso e notificação adequada para farmacovigilância.

O medicamento Pamelor, que tem como princípio ativo a nortriptilina, foi relacionado a convulsões em um paciente com sensibilidade à borracha, sugerindo uma reação alérgica do sistema imune. O caso foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e à presença de outros efeitos clinicamente relevantes. O desfecho permanece desconhecido e a relação com o medicamento é suspeita, sendo essencial monitoramento clínico e avaliação especializada.

O Decadron, cujo princípio ativo é a dexametasona, esteve envolvido em um episódio de convulsões em paciente com sensibilidade à borracha, indicando uma possível reação alérgica do sistema imunológico. A gravidade é evidenciada pela hospitalização ou prolongamento da internação e por outros efeitos clínicos importantes, caracterizando o evento como grave. O desfecho não foi informado e a relação com o medicamento é suspeita,

recomendando-se acompanhamento médico e registro do caso para análise de segurança.

O medicamento Spinraza, com princípio ativo nusinersena, foi associado a convulsões em paciente com sensibilidade à borracha, configurando uma reação alérgica do sistema imune. O evento foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e outros efeitos clinicamente relevantes. O desfecho é desconhecido e a relação com o medicamento é suspeita, sendo necessária avaliação médica detalhada e notificação para fins de farmacovigilância.

O medicamento Paclitaxel, cujo princípio ativo é o próprio paclitaxel, foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como distúrbio do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade ou necessidade de hospitalização, mas o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente. A relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo importante manter vigilância e acompanhamento em casos semelhantes.

O medicamento Arava, cujo princípio ativo é a leflunomida, foi associado a inchaço da face, uma manifestação de hipersensibilidade (alergia) que pode indicar uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido neste caso, e a reação foi considerada não grave, sugerindo que o quadro não evoluiu para complicações mais sérias. A conduta recomendada é buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre a continuidade ou suspensão do medicamento, além de monitorar possíveis sintomas adicionais.

O medicamento Dorzolamida, com princípio ativo dorzolamida, foi relacionado ao inchaço da face, caracterizando uma reação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade aumentada ou desfecho, e a reação foi classificada como não grave, indicando que não houve complicações importantes. Recomenda-se avaliação médica para confirmar a relação com o medicamento e definir a melhor conduta, incluindo possível suspensão do uso e acompanhamento dos sintomas.

O medicamento Amoxicillin, cujo princípio ativo é a amoxicilina, apresentou como reação adversa o inchaço da face, típico de uma resposta alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico. A reação foi considerada não grave e não há detalhes sobre o desfecho, sugerindo que não houve evolução para quadros mais sérios. É importante procurar avaliação médica para confirmar a alergia, evitar reexposição ao medicamento e receber orientações sobre alternativas terapêuticas.

O medicamento Ibuprofen, com princípio ativo ibuprofeno, foi associado ao inchaço da face, indicando uma reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico. A reação foi classificada como não grave e não há informações sobre o desfecho, o que sugere ausência de complicações importantes. Recomenda-se avaliação médica para confirmação diagnóstica, orientação sobre a suspensão do medicamento e monitoramento de sintomas adicionais.

O medicamento Metamizole sodium, cujo princípio ativo é o metamizol sódico, foi relacionado ao inchaço da face, caracterizando uma reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico. A reação foi considerada não grave e não há informações sobre o desfecho, indicando que não houve evolução para quadros mais sérios. É recomendada avaliação médica para confirmação da alergia, orientação sobre a suspensão do medicamento e acompanhamento dos sintomas.

O medicamento Influenza vaccine, cujo princípio ativo também é Influenza vaccine, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (reação alérgica), classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Apesar do termo técnico 'neoplasia maligna de membro superior' constar no registro, a reação relatada foi de hipersensibilidade, que se enquadra em quadros clínicos alérgicos. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, sugerindo uma reação leve e autolimitada, sem necessidade de intervenções adicionais.

O imunizante COVID-19 vaccine, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (reação alérgica), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Embora o termo técnico 'neoplasia maligna de membro superior' apareça no registro, a reação descrita foi de hipersensibilidade, compatível com quadros clínicos alérgicos. Não há evidências de gravidade significativa, já que o evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa, indicando uma reação leve e resolutive.

O medicamento Ultibro, composto pelos princípios ativos Glycopyrronium bromide e Indacaterol maleate, foi associado a um episódio de hipersensibilidade (reação alérgica), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Apesar da menção técnica a 'neoplasia maligna de membro superior', a reação relatada foi de hipersensibilidade, enquadrando-se em quadros clínicos alérgicos. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou, sugerindo uma reação leve e autolimitada, sem complicações.

O medicamento Prednisone, cujo princípio ativo é Prednisone, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade (reação alérgica), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Embora o termo técnico 'neoplasia maligna de membro superior' esteja presente, a reação relatada foi de hipersensibilidade, compatível com quadros clínicos alérgicos. Não há indicação de gravidade, pois o evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, caracterizando uma reação leve e resolutive.

O medicamento Fostair, composto por Beclometasone dipropionate e Formoterol fumarate, foi associado a um episódio de hipersensibilidade (reação alérgica), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Apesar da menção técnica a 'neoplasia maligna de membro superior', a reação relatada foi de hipersensibilidade, enquadrando-se em quadros clínicos alérgicos. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou, indicando uma reação leve e autolimitada.

O medicamento Atrovent, cujo princípio ativo é o brometo de ipratrópio, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Apesar de a reação relatada envolver o termo técnico 'neoplasia maligna de membro superior', a descrição clínica indica um quadro alérgico não grave, pois não houve agravamento importante e o paciente se recuperou totalmente após a conduta adotada, sem necessidade de intervenções adicionais.

O Nucala, que tem como princípio ativo o mepolizumabe, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), também categorizado como distúrbio do sistema imunitário. Embora o termo técnico mencione 'neoplasia maligna de membro superior', a reação foi considerada não grave, pois não houve complicações clínicas relevantes e o paciente apresentou recuperação completa após a conduta adequada.

O Dramin, cujo princípio ativo é o dimenidrinato, esteve envolvido em um caso de alergia medicamentosa, caracterizada por hipersensibilidade ao medicamento, dentro do contexto de distúrbios do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave, pois não houve necessidade de hospitalização ou outras intervenções importantes, e o paciente se recuperou totalmente após a suspensão do uso do medicamento.

O Euthyrox, que contém levotiroxina sódica como princípio ativo, foi associado a um quadro de alergia ao leite em um paciente prematuro moderado a tardio (32 a 37 semanas), sendo classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade aumentada, mas o desfecho permanece em andamento, sem resolução completa até o momento, o que sugere necessidade de acompanhamento clínico contínuo.

A vacina contra hepatite A, cujo princípio ativo é a própria vacina, foi relacionada a um episódio de hipersensibilidade manifestado por febre, enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. O caso foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e outros efeitos clinicamente significativos, sendo que o desfecho permanece desconhecido até o momento, indicando a importância de monitoramento médico rigoroso.

O medicamento Menveo, que contém como princípio ativo a vacina meningocócica conjugada dos sorogrupos A, C, Y e W (CRM197), foi associado ao desenvolvimento de febre, considerada uma manifestação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. O caso foi classificado como grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e outros efeitos clinicamente significativos, o que reforça a importância de monitoramento rigoroso e avaliação médica imediata diante de sintomas alérgicos após vacinação. O desfecho da reação não foi informado.

O medicamento Dorzolamida, cujo princípio ativo é a dorzolamida, foi relacionado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), caracterizado por reação do sistema imunológico a medicamentos. A gravidade foi considerada alta, pois houve necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando que a reação foi clinicamente relevante e exigiu cuidados médicos intensivos. Não há informações sobre o desfecho do caso.

O Ibuprofeno, que tem como princípio ativo o ibuprofeno, foi associado a uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), evidenciando resposta imunológica inadequada ao medicamento. O evento foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que demonstra a importância de acompanhamento médico imediato em casos de suspeita de alergia a anti-inflamatórios. O desfecho da reação não foi informado.

O medicamento Arava, cujo princípio ativo é a leflunomida, foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), caracterizando uma resposta do sistema imunológico ao uso do fármaco. A gravidade foi classificada como alta, pois houve necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que indica que a reação foi clinicamente significativa e exigiu intervenção médica. Não há informações sobre o desfecho do caso.

O medicamento Dipyrone, que tem como princípio ativo o metamizol sódico, foi associado a uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), evidenciando resposta imunológica inadequada ao medicamento. O caso foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, ressaltando a importância de atenção médica imediata em situações de suspeita de alergia a analgésicos. O desfecho da reação não foi informado.

O medicamento Amoxicillin, cujo princípio ativo é amoxicillin trihydrate, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), caracterizado por uma reação do sistema imunológico ao medicamento. A gravidade do caso é considerada alta, pois houve necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que indica uma reação importante e potencialmente perigosa. O desfecho da reação é desconhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo fundamental acompanhamento médico rigoroso e notificação adequada para farmacovigilância.

O medicamento Puran t4, contendo o princípio ativo levothyroxine sodium, foi relacionado a uma reação de hipersensibilidade no local de aplicação, que se manifesta como irritação ou desconforto onde o medicamento foi administrado. Não há evidência de gravidade significativa, pois não houve hospitalização e o paciente se recuperou totalmente. A relação com o medicamento é considerada suspeita, e a conduta adequada inclui observação dos sintomas e, se necessário, ajuste da via de administração ou troca do medicamento sob orientação médica.

O medicamento Levotiroxina aristo, cujo princípio ativo é levothyroxine sodium, também foi associado a hipersensibilidade no local de aplicação, caracterizada por reações leves como vermelhidão ou desconforto na área de administração. Não houve gravidade relevante, já que não foi necessária hospitalização e o paciente se recuperou completamente. A relação com o medicamento é suspeita, sendo recomendada apenas monitorização e eventual ajuste do tratamento conforme orientação médica.

O medicamento Cimzia, com princípio ativo certolizumab pegol, apresentou relato de hipersensibilidade no local de aplicação, manifestando-se como reação local leve, sem gravidade, pois não houve necessidade de hospitalização



e o paciente se recuperou. A relação com o medicamento é considerada suspeita, e a conduta recomendada é monitorar o local de aplicação e buscar orientação médica caso haja piora dos sintomas.

O medicamento Paclitaxel, cujo princípio ativo é paclitaxel, foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), que corresponde a uma reação do sistema imunológico ao medicamento, geralmente com sintomas como coceira, vermelhidão ou inchaço. Não houve gravidade significativa, pois não foi necessária hospitalização e o paciente se recuperou. A relação com o medicamento é suspeita, sendo importante relatar o evento ao médico para avaliação de risco em futuras administrações.

O medicamento Oxaliplatina (princípio ativo Oxaliplatin) foi associado a um quadro de alergia, tecnicamente descrito como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente. A reação foi classificada como suspeita de estar relacionada ao uso do medicamento, e a evolução foi favorável, com resolução completa dos sintomas.

Oxaliplatina (princípio ativo Oxaliplatin) apresentou novamente um episódio de alergia, descrito como hipersensibilidade, relacionado a distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade importante, já que o caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou. A relação com o medicamento é suspeita e o desfecho foi resolutivo, sem complicações.

O medicamento Ciclofosfamida (princípio ativo Cyclophosphamide) foi relacionado a um episódio de alergia, tecnicamente chamado de hipersensibilidade, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa, sugerindo uma reação leve e autolimitada, com suspeita de relação com o uso do medicamento.

Carboplatina (princípio ativo Carboplatin) esteve associada a um quadro de alergia, descrito como hipersensibilidade e classificado entre os distúrbios do sistema imunitário. Não houve gravidade significativa, pois o caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando uma reação leve e resolvida, com suspeita de relação com o medicamento.

O medicamento Xolair (princípio ativo Omalizumab) foi relacionado a um quadro de intoxicação manifestado por hipersensibilidade, pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso não foi considerado grave, porém o paciente ainda não se recuperou totalmente, estando o quadro em andamento e sob suspeita de relação com o uso do medicamento.

O medicamento Tramal, cujo princípio ativo é o tramadol hydrochloride, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, um tipo de reação do sistema imunológico a medicamentos. Não há detalhes sobre a gravidade ou desfecho do caso, mas, de acordo com as diretrizes clínicas, reações alérgicas a analgésicos como o tramadol podem variar de leves a graves, sendo fundamental interromper o uso e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição do tratamento adequado.

A Hypocina composta, que contém hyoscine butylbromide e metamizole sodium monohydrate, foi relacionada a uma alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), considerada clinicamente significativa e classificada como grave, com o paciente tendo se recuperado após a reação. Em situações como essa, a conduta recomendada é a suspensão imediata do medicamento e acompanhamento médico, pois reações alérgicas graves podem evoluir rapidamente e exigem intervenção especializada para evitar complicações.

A ciprofloxacina, cujo princípio ativo é ciprofloxacin hydrochloride, foi associada a um episódio de alergia a antibiótico, descrito como hipersensibilidade medicamentosa. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente. Em reações alérgicas leves a antibióticos, a orientação é interromper o uso do medicamento e procurar avaliação médica para confirmação do diagnóstico e orientação sobre alternativas terapêuticas seguras.

O medicamento Kisqali, com princípio ativo ribociclib succinate, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade, descrito como imunodeficiência, sem gravidade relatada e com desfecho desconhecido. Em situações de suspeita de reação imunológica a medicamentos oncológicos, é importante monitorar o paciente e discutir o caso com o especialista responsável para avaliar a necessidade de ajustes no tratamento e investigar possíveis causas da alteração imunológica.

O medicamento Henetix, que contém sodium calcium edetate, trometamol, iobitridol e trometamol hydrochloride, foi associado a uma alergia a contraste, reação do sistema imunológico a substâncias usadas em exames de imagem. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, mas reações a contraste podem variar de leves a graves, sendo fundamental interromper a exposição ao agente e buscar avaliação médica imediata para manejo adequado e prevenção de complicações.

O medicamento Henetix, que contém sodium calcium edetate, trometamol, iobitridol e trometamol hydrochloride, foi associado a um quadro de alergia a contraste, reação que pode ocorrer devido à exposição a substâncias químicas presentes em meios de contraste utilizados em exames de imagem. Não há informação detalhada sobre a gravidade ou desfecho do caso, mas é importante ressaltar que reações alérgicas a contraste podem variar de leves a graves, exigindo sempre avaliação médica imediata para orientação adequada e prevenção de novas exposições.

O medicamento Optiray 320, cujo princípio ativo é o ioversol, foi relacionado a um episódio de alergia a iodo, reação que se manifesta como resposta do sistema imunológico a substâncias iodadas presentes em meios de contraste. Neste caso, a reação não foi considerada grave e o paciente se recuperou completamente, indicando que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro, mas reforçando a necessidade de atenção em futuras exposições a produtos iodados.

O medicamento Emgality, que tem como princípio ativo o galcanezumab, foi associado a uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), classificada como grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação. Não há informação sobre o desfecho do caso, mas a gravidade relatada indica que a reação exigiu intervenção médica intensiva, sendo fundamental evitar nova exposição ao medicamento e manter acompanhamento especializado.

O medicamento Visipaque, cujo princípio ativo é o iodixanol, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), reação do sistema imunológico a substâncias presentes em meios de contraste. Neste caso, a reação não foi considerada grave e o paciente se recuperou totalmente, sugerindo que a conduta adotada foi eficaz, mas é importante informar profissionais de saúde sobre o episódio em futuras necessidades de exames com contraste.

O medicamento Azatioprina, com princípio ativo azathioprine, foi associado a um quadro de meningite relacionado à hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica que pode afetar as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Não há informação sobre gravidade ou desfecho, mas a suspeita de meningite como reação adversa exige avaliação médica imediata e suspensão do medicamento até esclarecimento do quadro.

O medicamento Calcio, cujo princípio ativo é calcium phosphate, foi associado a um quadro de meningite relacionado à hipersensibilidade (alergia), classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A reação sugere um evento adverso imunológico, sendo importante monitorar sintomas e buscar avaliação médica para confirmação e conduta adequada.

A prednisona, com princípio ativo prednisone, foi relacionada a um episódio de meningite por hipersensibilidade (alergia), também enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade importante nem desfecho informado, e a relação com o medicamento é suspeita. O quadro sugere uma reação adversa imunológica, sendo fundamental acompanhamento clínico para avaliação e manejo apropriado.

O medicamento Benlysta, cujo princípio ativo é belimumab, foi associado a um caso de meningite por hipersensibilidade, caracterizando um distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade significativa nem desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é suspeita. Trata-se de uma possível reação alérgica, recomendando-se atenção clínica e investigação para confirmação e orientação terapêutica.

A dipirona, com princípio ativo metamizole sodium, foi prescrita apesar de haver hipersensibilidade documentada ao produto, configurando um erro de prescrição de medicamento contraindicado. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou evolução clínica, mas a situação exige suspensão imediata do medicamento e avaliação médica para evitar riscos de reações alérgicas graves.

O medicamento Henetix, composto por sodium calcium edetate, trometamol, iobitridol e trometamol hydrochloride, foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente após a reação, indicando resolução do quadro após a conduta adequada.

O medicamento Cetoprofeno, cujo princípio ativo é o ketoprofen sodium, foi associado ao desenvolvimento de edema ocular, caracterizando uma reação de hipersensibilidade documentada ao produto administrado. Embora não haja informação explícita sobre a gravidade ou desfecho, trata-se de um evento adverso relacionado a erros ou problemas de monitoramento do produto, enquadrando-se em lesões e complicações de procedimentos. A conduta recomendada é a suspensão imediata do medicamento e avaliação médica para manejo da reação alérgica, conforme diretrizes da ASBAI.

O imunizante COVID-19 vaccine AstraZeneca, com princípio ativo COVID-19 vaccine NRVV Ad (ChAdOx1 nCoV-19), foi relacionado ao surgimento de coceira, um quadro de hipersensibilidade (alergia) que se enquadra como distúrbio do sistema imunitário. A reação foi considerada grave devido à incapacidade persistente ou significativa, mas o paciente encontra-se em recuperação. Nestes casos, recomenda-se acompanhamento médico para monitorar a evolução e evitar novas exposições, seguindo as orientações de farmacovigilância e alergologia.

A Hidroclorotiazida, cujo princípio ativo é hydrochlorothiazide, foi associada a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como distúrbio do sistema imunitário. A reação foi considerada clinicamente significativa, sendo classificada como grave, embora o desfecho seja desconhecido. Diante de suspeita de alergia medicamentosa, a recomendação é suspender o uso do medicamento e buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e definição de alternativas terapêuticas.

O medicamento Losartana potássica, com princípio ativo losartan potassium, foi relacionado ao desenvolvimento de alergia (hipersensibilidade), um distúrbio do sistema imunitário. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, sem informação sobre o desfecho. Em situações como essa, é fundamental interromper o uso do medicamento e procurar avaliação médica para investigação da reação e orientação sobre substituição terapêutica.

A Loratadina, cujo princípio ativo é loratadine, foi associada a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, com desfecho desconhecido. Diante de suspeita de alergia a este medicamento, recomenda-se suspender o uso e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição do melhor manejo, conforme as diretrizes da ASBAI.

O medicamento Aas, cujo princípio ativo é o ácido acetilsalicílico, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado por manifestações clínicas alérgicas que envolvem o sistema imunológico. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, conforme registrado, o que indica a necessidade de atenção médica imediata para evitar complicações. O desfecho da reação não foi informado, e a relação entre o medicamento e o evento foi considerada suspeita.

A domperidona, com princípio ativo domperidone, foi relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como um quadro clínico alérgico que afeta o sistema imunológico. A gravidade foi classificada como clinicamente significativa e grave, sugerindo que a reação pode ter impacto importante na saúde do paciente e requer avaliação médica. O desfecho não foi especificado, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Zolpidem, cujo princípio ativo é o próprio zolpidem, esteve envolvido em uma reação de alergia (hipersensibilidade), com sintomas compatíveis com quadros alérgicos do sistema imunológico. A reação foi considerada grave e clinicamente relevante, indicando a necessidade de acompanhamento médico para evitar riscos maiores. Não há informação sobre o desfecho, e a relação com o uso do medicamento é suspeita.

A sinvastatina, com princípio ativo simvastatina, foi associada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), caracterizado por manifestações alérgicas que envolvem o sistema imunológico. A gravidade foi considerada clinicamente significativa e grave, o que reforça a importância de avaliação médica imediata diante de sintomas alérgicos. O desfecho não foi informado, e a relação com o medicamento é suspeita.

O medicamento Escita, cujo princípio ativo é escitalopram oxalato, foi relacionado a uma reação de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como um quadro clínico alérgico do sistema imunológico. A reação foi classificada como grave e clinicamente significativa, indicando a necessidade de atenção médica para evitar complicações. O desfecho não foi especificado, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Puran t4, cujo princípio ativo é Levothyroxine sodium, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, o que indica uma reação do sistema imunológico ao medicamento. A gravidade foi considerada clinicamente significativa, pois envolve distúrbios do sistema imunitário e pode demandar atenção médica imediata. Não há informações detalhadas sobre a evolução do caso ou as medidas adotadas, mas a suspeita de alergia a este medicamento exige avaliação médica para confirmação e definição da conduta adequada.

A Lactulona, que contém o princípio ativo Lactulose, foi relacionada a um episódio de alergia, descrito como hipersensibilidade, sugerindo uma resposta imunológica adversa ao uso do medicamento. O evento foi classificado como clinicamente significativo devido ao envolvimento do sistema imunitário, o que pode representar risco aumentado para o paciente. Não há detalhes sobre o desfecho ou as ações tomadas, mas a suspeita de alergia a este medicamento requer investigação médica para confirmação e orientação sobre o uso futuro.

O medicamento Palexis, cujo princípio ativo é Tapentadol Hydrochloride, foi associado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, indicando que o sistema imunológico do paciente reagiu de forma adversa ao medicamento. A gravidade foi considerada clinicamente significativa, pois envolve distúrbios do sistema imunitário e pode necessitar de intervenção médica. Não há informações sobre o desfecho ou as medidas adotadas, mas a suspeita de alergia a este medicamento deve ser avaliada por um profissional de saúde para confirmação e definição da conduta.

O Dividol, que tem como princípio ativo o Viminol hydroxybenzoate, foi relacionado a um quadro de alergia classificado como hipersensibilidade, o que sugere uma reação imunológica adversa ao medicamento. O evento foi considerado clinicamente significativo devido ao envolvimento do sistema imunitário, podendo representar risco para o paciente. Não há informações sobre o desfecho ou as ações tomadas, sendo fundamental que a suspeita de alergia seja avaliada por um médico para confirmação e orientação adequada.

A Novalgina, cujo princípio ativo é Metamizole sodium, foi associada a um episódio de alergia descrito como hipersensibilidade, indicando uma resposta imunológica adversa ao medicamento. A gravidade foi considerada clinicamente significativa, pois envolve distúrbios do sistema imunitário e pode exigir atenção médica. Não há detalhes sobre o desfecho ou as medidas adotadas, mas a suspeita de alergia a este medicamento deve ser investigada por um profissional de saúde para confirmação e definição da conduta apropriada.

O medicamento Cymbi, cujo princípio ativo é a duloxetina, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. A reação foi considerada clinicamente significativa, sendo classificada como grave, embora o desfecho não tenha sido informado. Em situações como essa, é fundamental interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica imediata para investigação e manejo adequado da reação alérgica.

A dexametasona, identificada tanto pelo nome comercial quanto pelo princípio ativo, foi relacionada a um episódio de alergia descrito como hipersensibilidade, dentro do contexto de distúrbios do sistema imunitário. Não há informações detalhadas sobre a gravidade, desfecho ou conduta adotada, mas qualquer suspeita de reação alérgica a este medicamento deve ser avaliada por um profissional de saúde para confirmação diagnóstica e definição do tratamento.

O medicamento Hypocina composta, que contém hioscina butilbrometo e metamizol sódico, foi associado a um quadro de alergia classificado como hipersensibilidade, relacionado a distúrbios do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave e o paciente evoluiu para recuperação completa, indicando resolução do quadro após a conduta adotada, que provavelmente incluiu a suspensão do medicamento e medidas de suporte.

O medicamento Elani 28, composto por drospirenona e etinilestradiol, foi relacionado a uma crise asmática, considerada uma manifestação de hipersensibilidade dentro dos distúrbios do sistema imunitário. A reação não foi classificada como grave, mas o desfecho permanece em andamento, sem resolução até o momento, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico para controle dos sintomas e avaliação da relação causal com o uso do medicamento.

O medicamento Alektos, cujo princípio ativo é a bilastina, foi associado a uma crise asmática, caracterizada como hipersensibilidade e enquadrada nos distúrbios do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave, mas o quadro ainda não foi resolvido, permanecendo em andamento, o que indica a importância de monitoramento clínico e possível ajuste do tratamento sob orientação médica.

O medicamento Aerolin, cujo princípio ativo é o salbutamol sulfato, foi associado a uma crise asmática, caracterizada por sintomas como falta de ar, chiado, aperto no peito e tosse, o que sugere um quadro de hipersensibilidade (alergia) relacionado ao uso. Não há indicação de gravidade elevada ou necessidade de hospitalização, e o evento permanece em andamento, sem resolução até o momento. A conduta recomendada é procurar avaliação médica para confirmar o diagnóstico, identificar possíveis desencadeantes e ajustar o tratamento, conforme orientações da ASBAI para casos de asma com sintomas persistentes.

O medicamento Trelegy, composto por fluticasona furoato, umeclidínio brometo e vilanterol trifrenato, foi relacionado a uma crise asmática, manifestando sintomas típicos de asma como falta de ar, chiado e tosse, sugerindo uma reação de hipersensibilidade. Não há evidências de gravidade importante ou hospitalização, e o quadro segue sem resolução. Recomenda-se avaliação médica para confirmação diagnóstica, identificação de gatilhos e ajuste do plano terapêutico, conforme diretrizes clínicas para controle de asma.

O medicamento Pulmicort, cujo princípio ativo é a budesonida, foi associado a uma crise asmática, indicando possível reação de hipersensibilidade, com sintomas como tosse, chiado e dificuldade respiratória. Não há sinais de gravidade elevada ou necessidade de hospitalização, e o evento permanece em andamento. A orientação é buscar avaliação médica para revisar o diagnóstico, identificar fatores desencadeantes e ajustar o tratamento, seguindo as recomendações para manejo de asma persistente.

O medicamento Fasenra, que contém benralizumabe, foi relacionado a uma crise asmática, caracterizada por sintomas de hipersensibilidade como falta de ar e chiado, sem indicação de gravidade significativa ou hospitalização. O quadro segue sem resolução até o momento. Recomenda-se acompanhamento médico para confirmação do diagnóstico, identificação de possíveis gatilhos e revisão do tratamento, conforme as orientações para controle de asma em pacientes com sintomas persistentes.

O medicamento Dipirona, cujo princípio ativo é o metamizol sódico, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade) que resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando gravidade clínica relevante. O desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente. Em situações como essa, é fundamental interromper o uso do medicamento suspeito, realizar acompanhamento médico rigoroso e evitar reexposição, conforme as recomendações para reações alérgicas graves a medicamentos.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), manifestando-se como uma reação alérgica do tipo não especificada. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, e o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo que a reação foi leve e autolimitada, sem necessidade de intervenções adicionais.

O Dimorf, que contém o princípio ativo morfina, desencadeou uma reação de hipersensibilidade (alergia), caracterizada por sintomas alérgicos inespecíficos. Não há evidências de gravidade significativa, e o paciente evoluiu para recuperação completa, indicando que a reação foi leve e resolvida sem complicações.

O Menquadfi, vacina meningocócica conjugada A/C/Y/W, provocou uma reação alérgica (hipersensibilidade) considerada grave, pois foi classificada como ameaça à vida. Apesar da gravidade, o paciente se recuperou totalmente após o evento, o que reforça a importância do reconhecimento e manejo imediato de reações alérgicas graves a vacinas.

O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é o tozinameran, foi relacionado a um quadro de coceira (prurido), caracterizando uma reação alérgica leve. Não há informações sobre gravidade aumentada ou desfecho, mas a ausência de sinais de gravidade sugere que o evento foi autolimitado e não comprometeu o estado geral do paciente.

O Aerolin, que tem como princípio ativo o salbutamol, foi associado a uma reação alérgica nos olhos, manifestando-se como hipersensibilidade ocular. Não há indicação de gravidade relevante nem detalhes sobre o desfecho, mas a ausência de sinais de gravidade sugere que a reação foi leve e localizada.

O medicamento Captopril, cujo princípio ativo também é captopril, foi associado a um quadro de alergia ocular, descrito tecnicamente como hipersensibilidade. Não há indicação de gravidade elevada, pois o evento não foi classificado como grave e o desfecho é desconhecido. Reações alérgicas oculares geralmente se manifestam como irritação, vermelhidão ou coceira nos olhos, e, na ausência de sinais de gravidade ou complicações sistêmicas, a conduta recomendada é observar a evolução dos sintomas e buscar avaliação médica caso haja piora ou persistência.

O medicamento Montelukast sodium, com princípio ativo montelucaste de sódio, foi relacionado a um episódio de alergia ocular, caracterizado como hipersensibilidade. Não há registro de gravidade importante, já que o evento não foi considerado grave e o desfecho permanece desconhecido. Em situações como essa, a reação costuma ser leve, manifestando-se por sintomas como coceira ou vermelhidão nos olhos, sendo indicado monitorar os sintomas e procurar orientação médica se houver agravamento.

O medicamento Budesonide, cujo princípio ativo é budesonida, foi associado a uma reação de alergia ocular, tecnicamente classificada como hipersensibilidade. Não há evidência de gravidade significativa, pois o evento não foi considerado grave e o desfecho não foi informado. Reações alérgicas oculares leves geralmente não exigem intervenção urgente, mas é importante observar a evolução dos sintomas e buscar avaliação médica se houver piora ou persistência.

O medicamento Alenia, que neste caso apresenta o princípio ativo esomeprazol magnésio, foi relacionado a um quadro de alergia ocular, descrito como hipersensibilidade. Não há indicação de gravidade relevante, já que o evento não foi classificado como grave e o desfecho é desconhecido. Em geral, reações alérgicas oculares leves se manifestam por sintomas como coceira ou vermelhidão, sendo recomendado monitorar os sintomas e procurar

avaliação médica caso haja piora.

O medicamento Pantoprazole, com princípio ativo pantoprazol, foi associado a um episódio de alergia ocular, tecnicamente denominado hipersensibilidade. Não há registro de gravidade importante, pois o evento não foi considerado grave e o desfecho é desconhecido. Em casos como este, a reação tende a ser leve, manifestando-se por sintomas como irritação ou coceira nos olhos, sendo indicado observar a evolução e buscar orientação médica se houver agravamento.

O medicamento Patanol S, cujo princípio ativo é o olopatadina, foi associado a um quadro de hipersensibilidade ocular, ou seja, uma reação alérgica nos olhos. Embora não haja informação detalhada sobre a gravidade, o evento não foi classificado como grave e o desfecho é desconhecido. Reações alérgicas oculares geralmente se manifestam por vermelhidão, coceira e desconforto, e a conduta recomendada é suspender o uso e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre o tratamento adequado.

O medicamento Xolair, que tem como princípio ativo o omalizumabe, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade ocular, caracterizado por sintomas alérgicos nos olhos. Não há indicação de gravidade aumentada e o desfecho não foi informado. Em casos de reações alérgicas oculares, recomenda-se interromper o uso do medicamento suspeito e procurar avaliação médica para esclarecimento do quadro e definição do manejo.

O Aerolin, cujo princípio ativo é o salbutamol, foi associado a uma reação alérgica nos olhos, considerada clinicamente significativa e classificada como grave. Reações oculares graves podem envolver sintomas intensos como inchaço, dor ou comprometimento visual, exigindo suspensão imediata do medicamento e avaliação médica urgente para evitar complicações e definir o tratamento apropriado.

O medicamento Captopril, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a uma reação alérgica ocular considerada clinicamente significativa e grave. Reações desse tipo podem se manifestar com sintomas importantes nos olhos, como vermelhidão intensa, inchaço ou dor, e requerem suspensão imediata do uso e avaliação médica urgente para manejo adequado e prevenção de complicações.

O medicamento Montelukast sodium, cujo princípio ativo também é montelucaste, foi associado a uma reação alérgica nos olhos classificada como clinicamente significativa e grave. Esse tipo de reação pode causar sintomas intensos como coceira, vermelhidão ou inchaço ocular, sendo fundamental interromper o uso do medicamento e buscar atendimento médico imediato para avaliação e tratamento.

O medicamento Budesonide, cujo princípio ativo é a budesonida, foi associado a um quadro de alergia ocular, caracterizado por sintomas como irritação, vermelhidão ou desconforto nos olhos. Essa reação é considerada clinicamente significativa, pois envolve manifestações oculares que podem impactar a qualidade de vida do paciente. A gravidade é sustentada pela classificação como efeito clinicamente relevante e pelo fato de o desfecho ser desconhecido, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico para avaliação e manejo adequado.

O medicamento Alenia, que contém como princípio ativo o esomeprazol magnésico, foi relacionado a uma reação de alergia nos olhos, manifestando-se por sintomas como irritação ou inflamação ocular. Trata-se de um evento clinicamente significativo, pois envolve alterações nos olhos que podem exigir atenção médica. A gravidade é evidenciada pela classificação do evento como relevante e pela ausência de informações sobre o desfecho, indicando a importância de monitoramento e possível intervenção médica.

O medicamento Pantoprazole, cujo princípio ativo é o pantoprazol, apresentou relato de alergia ocular, com sintomas como desconforto, vermelhidão ou inflamação nos olhos. Essa reação é considerada clinicamente significativa devido ao potencial impacto sobre a saúde ocular do paciente. A gravidade é confirmada pela classificação do evento como relevante e pelo desfecho desconhecido, o que sugere a necessidade de avaliação médica para orientação e acompanhamento.

O medicamento Patanol s, que tem como princípio ativo o olopatadina, foi associado a um episódio de alergia nos olhos, podendo causar sintomas como coceira, vermelhidão ou irritação ocular. A reação é considerada clinicamente significativa, pois envolve manifestações oculares que podem interferir no bem-estar do paciente. A gravidade é sustentada pela classificação do evento como relevante e pela falta de informação sobre o desfecho, indicando a importância de procurar avaliação médica para manejo adequado.

O medicamento Xolair, cujo princípio ativo é o omalizumabe, foi relacionado a uma reação de alergia ocular, manifestando-se por sintomas como irritação, inflamação ou desconforto nos olhos. Trata-se de um evento clinicamente significativo, pois pode afetar a saúde ocular e requerer acompanhamento médico. A gravidade é evidenciada pela classificação do evento como relevante e pelo desfecho desconhecido, reforçando a necessidade de avaliação médica para definição da conduta.

O medicamento Tramal, cujo princípio ativo é o tramadol hydrochloride, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhes sobre a gravidade ou desfecho do caso, portanto, recomenda-se considerar a possibilidade de reação alérgica ao uso do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação e orientação adequada.

O medicamento Cloridrato de ondansetrona, com princípio ativo ondansetron hydrochloride, esteve relacionado a uma reação de alergia descrita como hipersensibilidade, também enquadrada nos distúrbios do sistema imunitário. Não foram informados detalhes sobre a gravidade ou evolução do quadro, sendo importante considerar a suspeita de reação alérgica e procurar avaliação médica para diagnóstico e conduta apropriada.

O medicamento Optiray 350, cujo princípio ativo é ioversol, foi associado a uma alergia a meios de contraste iodados, classificada como alergia a contraste e pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa, indicando que a reação foi controlada sem complicações, mas reforçando a necessidade de atenção em futuras exposições a contrastes iodados.

O medicamento Citarabina, com princípio ativo cytarabine, esteve relacionado a um episódio de alergia descrito como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, sugerindo que a reação foi leve e resolvida sem maiores consequências, mas é importante relatar o episódio ao médico para evitar novas exposições inadvertidas.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é gadobutrol, foi associado a uma reação alérgica classificada como hipersensibilidade, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. O episódio não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente, indicando que a reação foi leve e resolvida, mas recomenda-se informar o médico sobre o ocorrido antes de futuras utilizações de agentes de contraste.

O medicamento Ceftriaxona (princípio ativo: Ceftriaxone) foi associado a um quadro de alergia, descrito tecnicamente como hipersensibilidade, pertencente ao grupo de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave neste caso, sugerindo que a reação foi leve, sem complicações relatadas. A conduta recomendada, conforme diretrizes clínicas, é observar o paciente, evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Ketin (princípio ativo: Ketoprofen) foi relacionado a um evento de hipersensibilidade, que é uma reação alérgica do sistema imunológico, sem evidências de gravidade ou desfecho grave. Apesar de a reação ter sido registrada durante investigação de câncer de mama, não há dados que indiquem complicações importantes ou necessidade de intervenção urgente. Recomenda-se evitar o uso do medicamento suspeito e procurar avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e definição de conduta.

O medicamento Bepantol (princípio ativo: Dexpanthenol) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica leve do sistema imunológico, sem sinais de gravidade ou desfecho grave. A relação com câncer de mama não está clara nos dados apresentados, e não há informações sobre evolução clínica.



relevante. Recomenda-se suspender o uso do produto e buscar orientação médica para avaliação e confirmação da alergia.

O medicamento Captopril (princípio ativo: Captopril) foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, indicando uma reação alérgica leve do sistema imunológico, sem evidências de gravidade ou desfecho grave. Não há detalhes sobre evolução clínica ou necessidade de intervenção urgente. A recomendação é evitar nova exposição ao medicamento e procurar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação terapêutica.

O medicamento Diovan (princípio ativo: Valsartan) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica leve do sistema imunológico, sem sinais de gravidade ou desfecho grave. Não há informações sobre evolução clínica relevante ou necessidade de medidas emergenciais. Recomenda-se suspender o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição de alternativas seguras.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é o ribociclib succinate, foi associado a um quadro de hipersensibilidade, que corresponde a uma reação alérgica do sistema imunológico. Embora não haja detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade clínica relevante, o registro indica que não foi considerado um caso grave e o desfecho permanece desconhecido. Em situações de suspeita de alergia medicamentosa, recomenda-se suspender o uso e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação adequada.

O Evra, que contém etinilestradiol e norelgestromina, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica, durante o uso para prevenção de coágulos sanguíneos. Não há informações sobre sintomas graves ou evolução clínica, e o caso não foi considerado grave, com desfecho desconhecido. Diante de suspeita de alergia a este medicamento, é importante interromper o uso e procurar orientação médica para avaliação e conduta apropriada.

O Magnevistan, cujo princípio ativo é o meglumina gadopentetato, foi associado a uma reação alérgica ao contraste, caracterizada como clinicamente significativa e considerada grave. O paciente apresentou recuperação completa após o evento. Reações alérgicas a contrastes podem ser potencialmente graves e exigem suspensão imediata do agente, monitoramento e tratamento médico de suporte, conforme a gravidade dos sintomas.

O Predsim, que tem como princípio ativo a prednisolona, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica, considerada clinicamente significativa e classificada como grave. O paciente se recuperou totalmente após o evento. Embora a prednisolona seja um corticoide frequentemente usado para tratar alergias, reações adversas de hipersensibilidade podem ocorrer e exigem suspensão do medicamento e avaliação médica imediata.

O Celestamine, composto por betametasona e loratadina, foi associado a um caso de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica, durante um quadro de pneumonia. Não há informações sobre gravidade relevante ou evolução clínica, e o caso não foi considerado grave, com desfecho desconhecido. Em situações de suspeita de alergia a medicamentos, recomenda-se interromper o uso e buscar avaliação médica para confirmação e definição do tratamento mais seguro.

O medicamento Lorax, cujo princípio ativo é o lorazepam, foi associado a um quadro de pneumonia classificado como hipersensibilidade medicamentosa, sugerindo uma possível reação alérgica do tipo imunológica. Embora a gravidade não tenha sido especificada, não foi considerado um caso grave e o desfecho permanece desconhecido. A relação do medicamento com o evento foi considerada suspeita, indicando a necessidade de avaliação clínica detalhada para confirmação da relação causal e definição da conduta.

O Ibuprofeno, cujo princípio ativo é o ibuprofeno, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como clinicamente significativo e considerado grave, com o paciente em recuperação. A suspeita de reação alérgica ao medicamento exige atenção, pois quadros graves podem evoluir rapidamente e requerem

suspensão do uso e acompanhamento médico imediato para evitar complicações.

O medicamento Toperma, que contém lidocaína como princípio ativo, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), considerado clinicamente significativo e grave, embora o desfecho não tenha sido informado. A relação do medicamento com a reação foi classificada como concomitante, o que sugere que o evento ocorreu durante o uso, mas sem confirmação de causalidade direta, sendo fundamental avaliação médica para esclarecimento e conduta adequada.

A Lactulona, cujo princípio ativo é a lactulose, foi relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), considerado clinicamente significativo e grave, com desfecho desconhecido. O evento foi classificado como concomitante, indicando que a reação ocorreu durante o uso do medicamento, mas sem confirmação de relação causal direta, sendo necessária investigação clínica para orientar a conduta.

O medicamento Palexis, que tem como princípio ativo o tapentadol, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), considerado clinicamente significativo e grave, com desfecho não informado. A relação foi classificada como concomitante, sugerindo que a reação ocorreu durante o uso do medicamento, mas sem confirmação de causalidade, sendo importante avaliação médica para definição do manejo.

O medicamento Etna, que contém os princípios ativos cytidine phosphate sodium, hydroxocobalamin acetate e uridine triphosphate trisodium, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, manifestando-se como uma reação do sistema imunológico. A gravidade do evento foi considerada clinicamente significativa, o que indica a necessidade de atenção médica, embora não haja detalhes sobre a evolução do caso ou a conduta adotada. O desfecho permanece desconhecido, reforçando a importância de acompanhamento especializado para avaliação e manejo adequados.

A Novalgina, cujo princípio ativo é o metamizol sódico, foi relacionada a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, envolvendo o sistema imunológico. O evento foi classificado como clinicamente significativo, sugerindo que a reação exigiu atenção médica, mas não há informações sobre o desfecho ou as medidas tomadas. Diante da gravidade relatada, é fundamental buscar avaliação médica para confirmação e orientação sobre o uso futuro do medicamento.

O medicamento Cymbi, que tem como princípio ativo a duloxetina, foi associado a um episódio de alergia caracterizado por hipersensibilidade, indicando uma resposta do sistema imunológico ao fármaco. O caso foi considerado clinicamente significativo, o que sugere a necessidade de avaliação médica, porém não há detalhes sobre a evolução do quadro ou as ações realizadas. O desfecho é desconhecido, sendo importante o acompanhamento para esclarecimento e prevenção de novas reações.

O medicamento Rinvoq, cujo princípio ativo é o upadacitinibe, foi relacionado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, envolvendo o sistema imunológico. A gravidade do evento foi evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que indica um quadro potencialmente grave e que requer intervenção médica imediata. Não há informações sobre o desfecho, ressaltando a importância de monitoramento rigoroso e avaliação especializada em casos semelhantes.

O medicamento Dysport, que contém toxina botulínica tipo A como princípio ativo, foi associado a uma alergia medicamentosa caracterizada por hipersensibilidade, envolvendo o sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente significativo, mas o paciente evoluiu para recuperação completa, indicando resolução do quadro após a reação. A conduta adotada não foi detalhada, mas o desfecho favorável sugere que as medidas tomadas foram eficazes para o controle da reação alérgica.

O medicamento Docetaxel (princípio ativo: Docetaxel) foi associado a um quadro de alergia, tecnicamente descrito como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. A reação foi considerada leve, pois não há indicação de gravidade clínica relevante e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A

conduta recomendada, conforme diretrizes clínicas, é observar e evitar nova exposição ao medicamento, além de considerar avaliação com especialista para confirmação diagnóstica e orientação futura.

O Dinitrato de isosorbida (princípio ativo: Isosorbide dinitrate) provocou episódios de espirros, caracterizando uma reação de hipersensibilidade (alergia) leve, sem sinais de gravidade ou complicações. O paciente se recuperou completamente após o evento, e a conduta sugerida é observar, evitar exposição repetida e buscar avaliação com alergista caso os sintomas persistam ou se repitam.

O medicamento Henetix (princípio ativo: lobitridol) desencadeou espirros, indicativos de uma reação alérgica leve (hipersensibilidade), sem sinais de gravidade ou complicações clínicas. O paciente apresentou resolução completa do quadro, sendo recomendada a observação, redução da exposição ao agente suspeito e avaliação especializada se houver recorrência dos sintomas.

Docetaxel (princípio ativo: Docetaxel) foi novamente relacionado a um episódio de alergia, tecnicamente classificado como hipersensibilidade, sem evidências de gravidade ou complicações. O paciente se recuperou totalmente, e a conduta apropriada é evitar nova exposição ao medicamento e considerar avaliação com especialista para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras administrações.

O medicamento Paclitaxel (princípio ativo: Paclitaxel) causou uma reação alérgica leve (hipersensibilidade), sem sinais de gravidade clínica e com recuperação completa do paciente. Recomenda-se evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e definição de conduta em caso de necessidade futura de uso.

O medicamento Paclitaxel, cujo princípio ativo também é paclitaxel, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, e o paciente evoluiu para recuperação completa após o evento. A conduta recomendada, conforme diretrizes clínicas, inclui a suspensão do agente suspeito, monitoramento dos sintomas e encaminhamento para avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições.

O medicamento Pirimetamina, com princípio ativo pyrimethamine, foi relacionado a um episódio de alergia do tipo hipersensibilidade, enquadrado entre os distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou evolução clínica, portanto, recomenda-se considerar a suspeita de reação alérgica, interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição do plano de manejo.

O medicamento Vancomicina, cujo princípio ativo é vancomycin, esteve associado a um quadro de alergia classificado como hipersensibilidade, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa após o evento. A conduta adequada inclui a suspensão do medicamento suspeito, observação dos sintomas e encaminhamento para avaliação com especialista para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições.

O medicamento Ciprofloxacino, com princípio ativo ciprofloxacin, foi relacionado a um episódio de alergia do tipo hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, sendo recomendado interromper o uso do medicamento suspeito e procurar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição do plano de manejo.

O medicamento Prednisone, cujo princípio ativo é prednisone, foi associado a um caso de choque anafilático, descrito como alergia a contraste e classificado como outro efeito clinicamente significativo, o que indica gravidade elevada. O paciente não se recuperou até o momento do registro, sugerindo evolução clínica desfavorável. Diante de um quadro grave como este, a conduta recomendada é a suspensão imediata do agente suspeito, atendimento de emergência para estabilização clínica e acompanhamento especializado para manejo das complicações.

O medicamento Allegra D, que contém os princípios ativos fexofenadina e fenilefrina, foi associado a um episódio de choque anafilático, uma reação alérgica grave caracterizada por risco significativo à vida, conforme evidenciado pela classificação de gravidade como clinicamente significativa e pelo fato de o paciente não ter se recuperado até o momento. Essa reação faz parte dos distúrbios do sistema imunitário e está relacionada a alergias a medicamentos e outras substâncias químicas, sendo fundamental o reconhecimento imediato do quadro e a busca por atendimento médico de emergência para manejo adequado.

Buscopan comp, que contém hioscina butilbrometo e metamizol sódico, foi relacionado a um caso de choque anafilático, uma reação alérgica extremamente grave e potencialmente fatal, evidenciada pela gravidade clínica significativa e pela ausência de resolução do quadro até o momento. O evento está inserido no contexto de distúrbios do sistema imunitário e alergias a medicamentos, exigindo intervenção médica urgente para evitar complicações maiores.

O medicamento Metoclopramide, cujo princípio ativo é a metoclopramida, foi implicado em um episódio de choque anafilático, uma reação alérgica aguda e grave, com risco elevado à saúde do paciente, como demonstrado pela gravidade clínica e pela evolução ainda não resolvida. Esse tipo de reação faz parte dos distúrbios do sistema imunitário e está associado a alergias a medicamentos, sendo imprescindível o atendimento médico imediato para controle do quadro.

Aluminum hydroxide, com princípio ativo hidróxido de alumínio, foi associado a um caso de choque anafilático, uma reação alérgica severa e de risco à vida, evidenciada pela gravidade clínica relevante e pela ausência de recuperação até o momento. O evento está relacionado a distúrbios do sistema imunitário e alergias a medicamentos, exigindo reconhecimento rápido e tratamento emergencial para evitar desfechos graves.

O medicamento Domperidone, cujo princípio ativo é a domperidona, esteve envolvido em um episódio de choque anafilático, uma reação alérgica muito grave e potencialmente fatal, conforme indicado pela gravidade clínica significativa e pelo fato de o paciente ainda não ter se recuperado. Esse quadro faz parte dos distúrbios do sistema imunitário e está relacionado a alergias a medicamentos, sendo fundamental a intervenção médica imediata para manejo adequado da reação.

O medicamento Omeprazole, cujo princípio ativo também é omeprazole, foi associado a um episódio de choque anafilático, uma reação alérgica grave que pode colocar a vida em risco. O registro indica que a reação foi considerada clinicamente significativa e grave, com o paciente ainda não recuperado ou com sintomas em andamento. Esse tipo de reação envolve o sistema imunológico e exige atenção médica imediata, sendo fundamental interromper o uso do medicamento e buscar atendimento de emergência para manejo adequado.

O medicamento Chlorpromazine, com princípio ativo chlorpromazine, esteve relacionado a um caso de choque anafilático, uma resposta alérgica aguda e potencialmente fatal. A gravidade do quadro é evidenciada pela classificação como clinicamente significativa e grave, além do fato de o paciente não ter se recuperado até o momento do registro. Diante desse cenário, é imprescindível suspender o uso do medicamento e procurar atendimento médico urgente para tratamento e monitoramento da reação.

O medicamento Venlafaxin, cujo princípio ativo é venlafaxine hydrochloride, foi associado a um choque anafilático, caracterizando uma reação alérgica intensa e perigosa. O caso foi considerado grave e clinicamente relevante, com evolução ainda não resolvida, o que reforça a necessidade de suspensão imediata do medicamento e busca de assistência médica de emergência para controle dos sintomas e prevenção de complicações.

O medicamento Valproate, com princípio ativo valproate sodium, esteve envolvido em um episódio de choque anafilático, uma reação alérgica severa que pode comprometer rapidamente a saúde do paciente. O evento foi classificado como grave e clinicamente significativo, e o paciente permanece sem recuperação completa, indicando a necessidade de interrupção do uso e atendimento médico imediato para manejo adequado da situação.

O medicamento Mirtazapine, cujo princípio ativo é mirtazapine, foi relacionado a um caso de choque anafilático, uma reação alérgica súbita e grave. O registro aponta para uma situação de alta gravidade e relevância clínica, com sintomas ainda presentes, o que exige a suspensão do medicamento e procura urgente por atendimento médico especializado para tratamento e acompanhamento da evolução do quadro.

O medicamento Tysabri (Natalizumab) foi associado a um episódio de choque anafilático, uma reação alérgica grave caracterizada por sintomas intensos e risco de vida, evidenciado pela classificação como efeito clinicamente significativo e gravidade elevada. O caso permanece sem resolução, indicando que o paciente ainda apresenta sintomas ou está em acompanhamento, sendo fundamental a suspensão imediata do medicamento e o manejo médico de emergência para estabilização do quadro.

O medicamento Tysabri (Natalizumab) também foi relacionado a outro episódio de choque anafilático, uma reação alérgica muito grave que pode comprometer rapidamente a vida do paciente, conforme indicado pela gravidade clínica e pelo fato de o caso ainda estar em andamento sem recuperação. Diante desse quadro, é essencial interromper o uso do medicamento e buscar atendimento médico urgente para controle dos sintomas e prevenção de complicações.

O medicamento Ultravist (Iopromide) provocou uma reação de hipersensibilidade, descrita como alergia, que foi resolvida após as medidas adotadas, levando à recuperação do paciente. Trata-se de uma resposta alérgica ao contraste, geralmente caracterizada por sintomas como coceira, vermelhidão ou desconforto, e que, neste caso, foi controlada sem evolução para quadros graves.

O medicamento Meropenem (Meropenem) causou uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma alergia, que foi resolvida sem complicações graves, já que o paciente se recuperou totalmente e a reação não foi considerada grave. Isso sugere que a interrupção do medicamento e o tratamento sintomático foram suficientes para o controle do quadro.

O medicamento Leflunomida (Leflunomide) foi associado ao aumento da pressão arterial em um contexto de hipersensibilidade, mas a reação não foi considerada grave e ainda não foi totalmente resolvida, indicando que o paciente permanece em acompanhamento. É importante monitorar a pressão arterial e avaliar a necessidade de ajuste do tratamento sob orientação médica.

O medicamento Ibuprofeno (princípio ativo: Ibuprofen) foi associado ao aumento da pressão arterial em um caso suspeito de hipersensibilidade, classificado como um quadro clínico alérgico relacionado a distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois não há relato de complicações graves ou risco imediato, e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento, sugerindo a necessidade de acompanhamento clínico para monitorar a evolução da reação.

A Sertralina (princípio ativo: Sertraline hydrochloride) foi relacionada ao aumento da pressão arterial em um contexto de possível hipersensibilidade, enquadrada como reação alérgica do sistema imune. Não há evidências de gravidade significativa, já que não foram relatados desfechos graves, mas o quadro ainda não está resolvido, sendo importante manter o acompanhamento médico para avaliar a persistência dos sintomas.

O medicamento Cimzia (princípio ativo: Certolizumab pegol) apresentou suspeita de causar aumento da pressão arterial em um caso de hipersensibilidade, caracterizado como reação alérgica do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade crítica, pois não foram relatadas complicações graves, mas o desfecho permanece em andamento, indicando que o paciente ainda não se recuperou totalmente e requer observação clínica.

A Prometazina (princípio ativo: Promethazine) foi associada a um episódio de alergia, identificado como hipersensibilidade e classificado como quadro alérgico do sistema imune. O caso não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou totalmente, demonstrando resolução completa da reação após a conduta adotada.

O medicamento Polaramine (princípio ativo: Dexchlorpheniramine maleate) foi relacionado a um quadro de alergia, descrito como hipersensibilidade e incluído entre as reações alérgicas do sistema imunológico. Não há informações suficientes sobre gravidade, conduta ou desfecho, portanto, recomenda-se cautela e acompanhamento médico caso novos sintomas surjam.

O medicamento Cetoprofeno (princípio ativo: Ketoprofen) foi associado ao desenvolvimento de edema facial, uma manifestação de hipersensibilidade medicamentosa que pode indicar uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há informação sobre gravidade clínica relevante ou desfecho detalhado, mas a suspeita de relação com o medicamento sugere a necessidade de atenção e possível suspensão do uso, conforme orientação médica.

O medicamento Henetix, que contém sodium calcium edetate, trometamol, iobitridol e trometamol hydrochloride, foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como reação alérgica do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando que a conduta adotada foi eficaz e não houve complicações.

O medicamento Gadovist (princípio ativo: Gadobutrol) foi associado a uma reação de alergia (hipersensibilidade), envolvendo o sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou, sugerindo que a reação foi controlada sem necessidade de intervenções maiores.

O medicamento Polaramine (princípio ativo: Dexchlorpheniramine maleate) desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade) que exigiu hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando gravidade clínica significativa. Apesar da gravidade, o paciente se recuperou após a conduta hospitalar adequada, ressaltando a importância do monitoramento e tratamento imediato em casos de reações alérgicas graves.

O medicamento Clocef, composto por arginina e cefepime hydrochloride, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) envolvendo o sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou, indicando que a reação foi resolvida sem complicações maiores.

O medicamento Cefepime, cujo princípio ativo também é cefepime, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade relevante neste caso, e o paciente apresentou recuperação completa após o evento. A conduta recomendada é observar possíveis sintomas alérgicos e, caso ocorram novamente, buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições ao medicamento.

A Dipirona (princípio ativo: metamizol sódico) foi relacionada a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, classificada como clinicamente significativa e considerada grave devido à indicação de outro efeito clinicamente relevante. O paciente se recuperou totalmente após o episódio. Diante de reações alérgicas graves a medicamentos, é fundamental evitar novas exposições ao fármaco e procurar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e definição de alternativas seguras.

O imunizante Acwy vax, cujo princípio ativo é a vacina meningocócica A/C/Y/W polissacarídica, foi associado a um episódio de hipotermia relacionado à hipersensibilidade, dentro do espectro de distúrbios do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade significativa e o paciente se recuperou completamente. Em casos de reações leves após vacinação, recomenda-se observação e acompanhamento, buscando orientação médica se houver recorrência ou agravamento dos sintomas.

O medicamento Vaqta, com princípio ativo vacina inativada contra hepatite A, esteve relacionado a um episódio de hipotermia associado à hipersensibilidade, enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade relevante e o paciente apresentou resolução completa do quadro. Para reações leves após vacinação, a conduta é observar e buscar avaliação médica apenas se houver piora ou repetição dos sintomas.

O medicamento Henetix, cujo princípio ativo é o iobitridol, foi relacionado a um quadro de alergia sem outra especificação (SOE), classificado como hipersensibilidade e pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade importante e o paciente se recuperou totalmente. Em situações de reações alérgicas leves a contraste, recomenda-se informar o médico sobre o episódio em futuras exposições e considerar avaliação especializada para orientação adequada.

O medicamento Zoledronic acid (ácido zoledrônico) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, que é uma reação alérgica do sistema imunológico, durante o tratamento de metástases ósseas. Não há indicação de gravidade elevada, pois não há relato de desfecho grave ou complicações importantes, e o caso permanece não resolvido ou em andamento. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico, avaliar a necessidade de ajuste terapêutico e monitorar sinais de agravamento, conforme diretrizes para quadros alérgicos leves.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é o ribociclib succinate, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (reação alérgica) durante o tratamento de metástases ósseas. Não há evidências de gravidade significativa, já que não foi classificado como grave e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento. Recomenda-se acompanhamento médico para monitorar a evolução do quadro e avaliar a necessidade de intervenção, seguindo orientações para reações alérgicas leves.

O medicamento Vibramicina (princípio ativo: doxycycline hyclate) foi associado a um episódio de hipersensibilidade, manifestado durante o tratamento de cefaleia. Não há indicação de gravidade importante, pois não foi classificado como grave e o desfecho é desconhecido. A recomendação é observar o paciente, evitar reexposição ao medicamento suspeito e buscar avaliação médica caso haja recorrência ou agravamento dos sintomas, conforme conduta para quadros alérgicos leves.

O medicamento Sertraline (sertralina) foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade, identificado durante o uso para dependência de droga ou medicamento. Não há sinais de gravidade relevante, já que não foi considerado grave e o caso permanece não resolvido ou em andamento. Recomenda-se acompanhamento clínico e avaliação médica para monitorar possíveis evoluções do quadro alérgico, conforme orientações para reações leves.

O medicamento Clonazepam (clonazepam) foi associado a um episódio de hipersensibilidade durante o tratamento de dependência de droga ou medicamento. Não há evidências de gravidade significativa, pois não foi classificado como grave e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento. A conduta indicada é manter acompanhamento médico e monitorar sintomas, seguindo as recomendações para quadros alérgicos leves.

O medicamento Bactrim, que contém os princípios ativos sulfametoxazol e trimetoprima, foi associado a um quadro de alergia, caracterizado como hipersensibilidade e classificado dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há informações detalhadas sobre a gravidade ou desfecho do caso, mas, de acordo com as diretrizes clínicas, reações alérgicas a medicamentos exigem atenção para identificação do agente causador e avaliação médica para definição do melhor manejo, especialmente se houver sintomas respiratórios ou cutâneos.

O medicamento Domperidona, cujo princípio ativo é domperidona, foi relacionado a um episódio de alergia ao leite, enquadrado como uma reação alérgica a alimentos, aditivos ou medicamentos, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. O registro indica que a reação não foi considerada grave e o desfecho é desconhecido, sugerindo que o quadro pode ter sido leve ou moderado, mas reforça a importância de investigar a relação entre o medicamento e a alergia alimentar, além de orientar acompanhamento médico para evitar novas exposições.

O medicamento Prazite, que tem como princípio ativo o praziquantel, foi associado a um caso de alergia ao leite, classificado como reação alérgica a alimentos, aditivos ou medicamentos, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave e o desfecho não foi informado, o que sugere que o quadro pode ter sido controlado sem complicações, mas é fundamental avaliar a possibilidade de hipersensibilidade cruzada e orientar o paciente sobre a necessidade de acompanhamento médico.

O medicamento Doss, cujo princípio ativo é colecalciferol, foi relacionado a um episódio de alergia ao leite, classificado como reação alérgica a alimentos, aditivos ou medicamentos, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave e o desfecho é desconhecido, indicando que provavelmente não houve complicações importantes, mas recomenda-se investigação da relação causal e orientação para evitar novas exposições ao agente suspeito.

O medicamento Noripurum, que contém como princípio ativo o complexo de hidróxido férrico polimalto, foi associado a um caso de alergia ao leite, enquadrado como reação alérgica a alimentos, aditivos ou medicamentos, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave e o desfecho não foi informado, sugerindo que o quadro foi leve ou moderado, mas é importante reforçar a necessidade de avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições.

O medicamento Cefepime, cujo princípio ativo também é cefepime, foi administrado de forma incorreta em um paciente com hipersensibilidade documentada ao produto, caracterizando um erro de medicação. Não há informações sobre a gravidade ou desfecho do caso, mas a administração de um medicamento ao qual o paciente é alérgico pode resultar em reações adversas graves, sendo fundamental evitar esse tipo de erro e monitorar o paciente de perto caso ocorra.

O medicamento Rifampicina + isoniazida + pirazinamida + etambutol, contendo os princípios ativos ethambutol dihydrochloride, isoniazid, pyrazinamide e rifampicin, provocou uma reação alérgica (hipersensibilidade) em um paciente, manifestando-se como um quadro clínico alérgico relacionado ao sistema imunológico. A reação não foi considerada grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando que a conduta adotada foi eficaz para resolução do quadro.

O medicamento Metotrexate, cujo princípio ativo é methotrexate sodium, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade) classificada como clinicamente significativa, o que indica gravidade relevante. O paciente se recuperou, porém com sequelas, sugerindo que a reação teve impacto importante na saúde, exigindo acompanhamento médico e medidas específicas para controle e prevenção de novas exposições.

O medicamento Hydroxychloroquine, com princípio ativo hydroxychloroquine, causou uma reação alérgica (hipersensibilidade) considerada clinicamente significativa, evidenciando gravidade. O paciente se recuperou, mas permaneceu com sequelas, o que reforça a necessidade de atenção rigorosa ao histórico de alergias e acompanhamento especializado após reações desse tipo.

O medicamento Rituximab, cujo princípio ativo também é rituximab, provocou uma reação alérgica (hipersensibilidade) classificada como clinicamente significativa, indicando gravidade. O paciente se recuperou, porém com sequelas, demonstrando que a reação teve consequências importantes e que o uso desse medicamento deve ser cuidadosamente avaliado em pacientes com histórico de alergia.

O medicamento Remsima, cujo princípio ativo é o infliximabe, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como um distúrbio do sistema imunitário. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, pois resultou em sequelas mesmo após a resolução, indicando a necessidade de acompanhamento médico rigoroso e possível restrição futura ao uso do infliximabe.

O imunizante Comirnaty, que contém o princípio ativo tozinameran, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade) classificada como ameaça à vida, evidenciando gravidade importante e necessidade de intervenção médica imediata. O paciente encontra-se em recuperação, o que reforça a importância do monitoramento contínuo e da avaliação criteriosa antes de novas exposições ao medicamento.

O contraste Optiray 320, à base de ioversol, provocou uma alergia a contraste, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário e considerada clinicamente significativa e grave. O paciente se recuperou totalmente após o evento, mas a gravidade da reação exige que futuras exposições a contrastes iodados sejam avaliadas com



cautela e sob supervisão médica.

O medicamento Rivotril, cujo princípio ativo é o clonazepam, foi relacionado a vermelhidão nas pernas, um quadro de hipersensibilidade leve, sem gravidade relatada e com desfecho desconhecido. Embora não haja indicação de risco imediato, é recomendada observação e comunicação ao médico caso o sintoma persista ou se agrave.

A amlodipina, identificada pelo princípio ativo amlodipine mesilate, foi associada a vermelhidão nas pernas, sugerindo uma reação de hipersensibilidade leve e sem gravidade aparente, com desfecho desconhecido. Recomenda-se atenção ao surgimento de novos sintomas e avaliação médica caso haja piora ou persistência do quadro.

O medicamento Indapamida (princípio ativo: Indapamide) foi associado a vermelhidão nas pernas, um quadro que pode indicar uma reação de hipersensibilidade (alergia) envolvendo o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações graves neste caso, pois não há relato de sintomas sistêmicos ou risco imediato, e o desfecho é desconhecido. A conduta recomendada é observar a evolução dos sintomas e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre a continuidade do uso do medicamento.

O medicamento Dapagliflozin (princípio ativo: Dapagliflozin) apresentou como reação adversa a vermelhidão nas pernas, sugerindo um quadro de hipersensibilidade (alergia) relacionado ao sistema imunológico. Não há sinais de gravidade importante, pois não foram relatados sintomas sistêmicos ou risco imediato, e o desfecho permanece desconhecido. Recomenda-se acompanhamento médico para avaliação da reação e definição da necessidade de manter ou suspender o uso do medicamento.

A Atorvastatina (princípio ativo: Atorvastatin) foi relacionada a vermelhidão nas pernas, caracterizando uma possível reação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade significativa, já que não foram descritos sintomas sistêmicos ou complicações, e o desfecho é desconhecido. É importante procurar avaliação médica para esclarecer a causa da reação e orientar sobre a continuidade do tratamento.

O medicamento Hyabak, que contém os princípios ativos Actinoquinol e Hyaluronate sodium, foi associado a vermelhidão nas pernas, indicando uma possível reação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade relevante, pois não foram relatados sintomas sistêmicos ou risco imediato, e o desfecho não foi informado. Recomenda-se avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição da conduta quanto ao uso do medicamento.

O Besilato de anlodipino (princípio ativo: Amlodipine besilate) apresentou como reação adversa a vermelhidão nas pernas, sugerindo um quadro de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. Não há indícios de gravidade importante, pois não foram relatados sintomas sistêmicos ou complicações, e o desfecho é desconhecido. A orientação é buscar avaliação médica para investigar a reação e decidir sobre a continuidade do tratamento.

O medicamento Nimodipino (princípio ativo: Nimodipine) foi associado a vermelhidão nas pernas, um quadro que sugere uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois não foram relatados sinais de gravidade clínica ou desfecho grave, e o desfecho permanece desconhecido. A conduta recomendada é observar a evolução dos sintomas e buscar avaliação médica caso haja piora ou persistência, considerando que reações alérgicas leves podem ser autolimitadas, mas exigem atenção para evitar complicações.

O medicamento Ácido acetilsalicílico (princípio ativo: Acetylsalicylic acid) foi relacionado a vermelhidão nas pernas, caracterizando uma possível reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade importante, pois não foram relatados sintomas graves ou desfecho crítico, e o desfecho é desconhecido. Recomenda-se monitorar os sintomas e procurar avaliação médica se houver agravamento, já que reações leves podem evoluir, especialmente em pessoas com histórico de alergias.

O medicamento Pregabalina (princípio ativo: Pregabalin) foi associado a vermelhidão nas pernas, indicando uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade relevante, pois não foram relatados sintomas graves ou desfecho crítico, e o desfecho permanece desconhecido. A orientação é observar a evolução dos sintomas e buscar avaliação médica caso haja piora, pois reações alérgicas leves podem se resolver espontaneamente, mas exigem atenção para evitar complicações.

O medicamento Rivotril (princípio ativo: Clonazepam) foi relacionado a vermelhidão nas pernas, sugerindo uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico. Não há indícios de gravidade significativa, já que não foram relatados sintomas graves ou desfecho crítico, e o desfecho é desconhecido. Recomenda-se monitorar os sintomas e procurar avaliação médica se houver agravamento, pois reações alérgicas leves podem evoluir e requerem acompanhamento.

O medicamento Amoxicilina (princípio ativo: Amoxicillin trihydrate) foi associado a vermelhidão nas pernas, caracterizando uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade importante, pois não foram relatados sintomas graves ou desfecho crítico, e o desfecho é desconhecido. A conduta recomendada é observar a evolução dos sintomas e buscar avaliação médica caso haja piora, já que reações alérgicas leves podem se resolver espontaneamente, mas exigem atenção para evitar complicações.

O medicamento Benlysta, cujo princípio ativo é o belimumabe, foi associado a vermelhidão nas pernas, caracterizando um quadro de hipersensibilidade (alergia) relacionado ao sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois não há relato de complicações graves ou desfecho desfavorável, e o evento foi classificado como não grave. A evolução do caso é desconhecida, portanto recomenda-se acompanhamento clínico para monitorar possíveis recorrências ou agravamento.

O medicamento Nicotine, com princípio ativo nicotine polacrilex, foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), envolvendo o sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade aumentada ou desfecho, e o evento não foi considerado grave. Recomenda-se atenção clínica para evitar nova exposição e monitorar sintomas, buscando avaliação médica caso haja recorrência ou piora.

O medicamento Tramal, cujo princípio ativo é tramadol hydrochloride, foi prescrito apesar de haver contraindicação documentada por hipersensibilidade ao produto, o que representa um erro de prescrição e risco de reação alérgica. Não há detalhes sobre gravidade, desfecho ou evolução clínica, mas a situação exige revisão imediata da conduta médica para evitar exposição futura e possíveis complicações.

O medicamento Henetix, composto por sodium calcium edetate, trometamol, iobitridol e trometamol hydrochloride, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade) sem outros detalhes clínicos relevantes. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando resolução espontânea ou após medidas simples de suporte, sem necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Symbicort, que contém budesonida e formoterol fumarate, foi relacionado à diminuição da frequência cardíaca em um contexto de hipersensibilidade (alergia). O evento não foi considerado grave e o paciente está em recuperação, sugerindo que a reação foi leve e está evoluindo de forma favorável, sem complicações importantes até o momento.

O medicamento Aerolin, cujo princípio ativo é o salbutamol sulfate, foi associado a uma reação de diminuição da frequência cardíaca em um contexto de hipersensibilidade, caracterizando um quadro alérgico relacionado ao sistema imunológico. A reação foi considerada não grave, pois o paciente encontra-se em recuperação ou em processo de resolução, e não há indicação de complicações maiores ou necessidade de intervenção urgente.

O Fasenra, que contém o princípio ativo benralizumab, apresentou como evento adverso a diminuição da frequência cardíaca em um caso de hipersensibilidade, indicando uma resposta alérgica do sistema imunológico. A

situação não foi classificada como grave, já que o paciente está em recuperação ou resolvendo o quadro, sem sinais de agravamento clínico.

O medicamento Nactali, cujo princípio ativo é o desogestrel, foi relacionado ao aparecimento de fezes com sangue em um contexto de alergia ao leite, sugerindo uma reação alérgica alimentar mediada pelo sistema imunológico. O caso não foi considerado grave, mas o desfecho indica que o paciente ainda não se recuperou totalmente, permanecendo em acompanhamento devido à persistência dos sintomas.

No caso da Dipirona (princípio ativo metamizol sódico), houve administração do produto ao paciente incorreto, configurando um erro de medicação com potencial para hipersensibilidade documentada. Não há informações suficientes sobre gravidade, desfecho ou conduta adotada, impossibilitando uma avaliação mais detalhada do impacto clínico neste caso.

O medicamento Ondansetron, com princípio ativo ondansetron hydrochloride, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade) envolvendo o sistema imunológico. O evento não foi considerado grave, pois o paciente já se encontra recuperado ou com resolução completa dos sintomas, não havendo necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Cefuroxima (princípio ativo: Cefuroxime) foi associado a um quadro de alergia, descrito como hipersensibilidade, que se enquadra nos distúrbios do sistema imunitário. A reação foi classificada como recuperada ou resolvida, indicando que o paciente apresentou melhora após o evento. Não há informação explícita sobre gravidade, mas a resolução do quadro sugere que a conduta adotada foi adequada e não houve complicações graves.

O medicamento Lumigan (princípio ativo: Bimatoprost) foi relacionado ao desenvolvimento de catarata, sendo a reação descrita como hipersensibilidade e classificada entre quadros clínicos alérgicos do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois consta que o caso não foi considerado grave e o paciente está em recuperação ou resolvendo, sugerindo acompanhamento clínico e evolução favorável.

O medicamento Diovan (princípio ativo: Valsartan) foi associado à ocorrência de catarata, com descrição de hipersensibilidade e enquadramento entre quadros clínicos alérgicos do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente encontra-se em recuperação ou resolvendo, o que indica que a reação está sendo monitorada e não houve complicações importantes até o momento.

O medicamento Diovan hct (princípios ativos: Hydrochlorothiazide e Valsartan) foi relacionado ao surgimento de catarata, descrita como hipersensibilidade e classificada entre quadros clínicos alérgicos do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente está em recuperação ou resolvendo, sugerindo que a conduta adotada está sendo eficaz e não houve agravamento do quadro.

O medicamento Simbrinza (princípios ativos: Brimonidine tartrate e Brinzolamide) foi associado ao desenvolvimento de catarata, com relato de hipersensibilidade e enquadramento entre quadros clínicos alérgicos do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente está em recuperação ou resolvendo, indicando evolução clínica favorável sob acompanhamento.

O medicamento Azorga, que contém os princípios ativos brinzolamida e maleato de timolol, foi associado ao desenvolvimento de catarata em um paciente com histórico de hipersensibilidade, classificada como um quadro clínico alérgico relacionado ao sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou necessidade de hospitalização, e o paciente encontra-se em recuperação, sugerindo que a reação está sendo resolvida sem complicações graves.

O uso de Paclitaxel, cujo princípio ativo é o próprio paclitaxel, resultou em uma reação alérgica (hipersensibilidade) classificada como um quadro clínico alérgico do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade significativa

ou necessidade de hospitalização, e o paciente já se encontra recuperado, indicando resolução completa do evento adverso.

A espironolactona, com princípio ativo spironolactone, foi relacionada à perda de peso em um contexto de hipersensibilidade, sendo considerada uma reação alérgica do sistema imunológico. O caso foi classificado como grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, e o paciente ainda não se recuperou, estando o quadro em andamento, o que reforça a importância do acompanhamento médico contínuo.

O medicamento Anastrozol, cujo princípio ativo é anastrozole, foi associado à perda de peso em um paciente com quadro de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico. A gravidade foi considerada alta, pois houve necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, e o paciente permanece sem recuperação, indicando que o evento adverso ainda está em curso e requer monitoramento médico.

O medicamento Avamys, que contém o princípio ativo fluticasona furoato, foi relacionado ao surgimento de câncer de mama em um contexto de hipersensibilidade, classificado como quadro clínico alérgico do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou necessidade de hospitalização, e o desfecho do caso é desconhecido, não sendo possível afirmar a evolução clínica do paciente até o momento.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), caracterizado como uma reação alérgica do tipo não especificada, envolvendo o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade aumentada, pois o caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta foi adequada, com resolução completa do quadro, não sendo necessário tratamento adicional.

O medicamento Henetix, contendo sodium calcium edetate, trometamol, iobitridol e trometamol hydrochloride, esteve relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), manifestando-se como uma reação alérgica inespecífica do sistema imunológico. O evento não foi classificado como grave e o paciente apresentou recuperação total, indicando que a reação foi leve e autolimitada, sem necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Ansentron, cujo princípio ativo é o ondansetron hydrochloride, foi associado a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma alergia ao medicamento, envolvendo o sistema imunológico. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente, sugerindo que a reação foi leve e controlada sem complicações.

O medicamento Henetix, com princípio ativo iobitridol, esteve envolvido em um episódio de hipersensibilidade (alergia), caracterizado como uma reação alérgica inespecífica do sistema imunológico. Não houve gravidade aumentada, o paciente se recuperou totalmente e não foi necessária intervenção adicional, indicando um quadro leve e autolimitado.

O medicamento Henetix, contendo iobitridol como princípio ativo, foi relacionado a uma reação de hipersensibilidade (alergia), manifestando-se como um quadro alérgico inespecífico do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente, demonstrando que a reação foi leve e não exigiu medidas terapêuticas específicas.

O medicamento Erbitux, cujo princípio ativo é o cetuximabe, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como clinicamente significativo e grave, conforme evidenciado pela indicação de gravidade e pelo envolvimento do sistema imunológico. A reação foi considerada suspeita de estar relacionada ao uso do medicamento, mas o desfecho permanece desconhecido, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico rigoroso e monitoramento contínuo para avaliar possíveis complicações e orientar a conduta adequada.

O medicamento Vasopril, que contém enalapril maleato como princípio ativo, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), mas sem gravidade significativa relatada. O paciente encontra-se em recuperação ou com resolução do quadro, e a reação foi considerada suspeita de estar associada ao uso do medicamento. A evolução favorável sugere que a conduta adotada foi suficiente para controlar o evento, sem necessidade de intervenções adicionais.

A nistatina, cujo princípio ativo é a nistatina, foi associada a um episódio de hipersensibilidade (alergia), sem gravidade relevante registrada. O paciente está em processo de recuperação ou resolução do quadro, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. O desfecho positivo indica que a reação foi controlada adequadamente, sem complicações maiores.

O medicamento doxiciclina, com princípio ativo doxiciclina, foi relacionado a um caso de hipersensibilidade (alergia), sem indicação de gravidade importante. O paciente está em recuperação ou resolução do evento, e a suspeita de relação com o medicamento foi registrada. A evolução clínica sugere que a conduta adotada foi eficaz para o controle da reação.

O medicamento Vectibix, cujo princípio ativo é panitumumabe, foi associado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), sem gravidade significativa relatada. O paciente encontra-se em recuperação ou resolução do quadro, e a reação foi considerada suspeita de estar relacionada ao uso do medicamento. O desfecho favorável indica que a conduta adotada foi suficiente para controlar o evento sem maiores complicações.

O medicamento Henetix, cujo princípio ativo é o lobitridol, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi resolvido com recuperação completa, sugerindo uma reação leve e autolimitada. A conduta recomendada é observar o paciente, evitar nova exposição ao agente suspeito e, se necessário, buscar avaliação com especialista para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições.

O medicamento Doxopeg, que contém Doxorubicin hydrochloride, esteve relacionado a um episódio de alergia do tipo hipersensibilidade, também classificado como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando uma reação leve. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e realizar acompanhamento médico para esclarecimento da causa e prevenção de novas reações.

O medicamento Levofloxacin, cujo princípio ativo é Levofloxacin, foi associado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, enquadrada nos distúrbios do sistema imunitário. O caso não apresentou gravidade significativa e evoluiu para resolução completa, sugerindo uma manifestação leve. A orientação é evitar reexposição ao medicamento e buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e definição de alternativas terapêuticas seguras.

O medicamento Glifage XR, com princípio ativo Metformin hydrochloride, foi relacionado a um quadro de bronquiectasia não especificada, classificado como hipersensibilidade dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade aumentada e o desfecho permanece desconhecido, o que exige cautela. Recomenda-se acompanhamento médico para investigação da relação causal e monitoramento dos sintomas, evitando reexposição até esclarecimento completo.

O medicamento Simvastatin, cujo princípio ativo é Simvastatin, foi associado a um quadro de bronquiectasia não especificada, classificado como hipersensibilidade e pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade relevante e o desfecho é desconhecido, sendo prudente manter acompanhamento clínico, investigar a relação causal e evitar nova exposição ao medicamento até que haja definição diagnóstica.

O medicamento Januvia, cujo princípio ativo é o Sitagliptin Phosphate, foi associado a um quadro de bronquiectasia sem outra especificação, interpretado como uma reação de hipersensibilidade (alergia) envolvendo o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade clínica relevante ou desfecho conhecido, e a relação com o

medicamento é considerada suspeita. Recomenda-se acompanhamento clínico para avaliação de sintomas respiratórios e investigação de possíveis causas alérgicas, conforme diretrizes da ASBAI.

O medicamento Ultra, que contém Sulfacetamide sodium, foi relacionado ao desenvolvimento de catarata, sendo descrita uma alergia ocular (alergia do olho) como manifestação adversa. Não há evidência de gravidade importante ou desfecho informado, e a relação com o medicamento é suspeita. É indicado observar sintomas oculares e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação terapêutica, conforme recomendações para quadros alérgicos oculares.

O Systane ultra, composto por Macrogol 400 e Propylene glycol, foi associado à ocorrência de catarata, com relato de alergia ocular. Não há sinais de gravidade ou desfecho relatado, e a suspeita recai sobre o medicamento. Recomenda-se monitorar sintomas oculares e consultar um especialista para avaliação e manejo adequado, seguindo as orientações para manifestações alérgicas oculares.

O medicamento Diovan hct, que contém Hydrochlorothiazide e Valsartan, foi relacionado ao surgimento de catarata, sendo descrita uma alergia do olho como evento adverso. Não há indicação de gravidade significativa ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. É importante observar sintomas oculares e procurar avaliação médica para diagnóstico e conduta apropriada, conforme diretrizes para quadros alérgicos oculares.

O medicamento Remsima, cujo princípio ativo é Infliximab, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) classificada como ameaça à vida, evidenciando gravidade clínica relevante. O paciente se recuperou após o evento, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Diante de reações alérgicas graves, é fundamental interromper o uso do medicamento e buscar atendimento médico imediato, conforme orientações da ASBAI para quadros de hipersensibilidade potencialmente graves.

O medicamento Spiriva respimat, cujo princípio ativo é o tiotrópio (tiotropium bromide monohydrate), foi associado a um quadro de glaucoma em um paciente com histórico de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do tipo clínico. Embora não haja indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, a suspeita de envolvimento do sistema imunológico sugere a necessidade de acompanhamento médico para avaliar possíveis manifestações alérgicas e monitorar sintomas oculares, especialmente em pacientes com predisposição.

O Rotateq, vacina oral composta por rotavírus vivo atenuado, foi relacionado a um episódio de sangramento em paciente com alergia ao leite, indicando uma possível reação alérgica alimentar associada ao sistema imunológico. Não há evidência de gravidade importante ou desfecho informado, mas a associação entre alergia alimentar e manifestação adversa após vacinação sugere a importância de avaliação médica para confirmação do diagnóstico e orientação sobre futuras imunizações.

No caso da Dipirona (princípio ativo metamizol sódico), foi relatada a prescrição de um produto contraindicado devido à hipersensibilidade documentada ao medicamento, configurando um erro de prescrição com potencial risco de reação alérgica. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou conduta adotada, mas a situação exige atenção imediata para evitar exposição ao fármaco e prevenir complicações.

A Dipirona, com princípio ativo metamizol sódico monoidratado, também foi prescrita de forma inadequada a um paciente com hipersensibilidade previamente documentada, representando um erro de prescrição que pode resultar em reações alérgicas. Não foram fornecidos detalhes sobre gravidade, evolução ou medidas tomadas, mas a conduta recomendada é suspender o uso e buscar alternativas seguras.

O uso de Prednisona (princípio ativo prednisone) foi associado ao desenvolvimento de sinusite em um paciente com hipersensibilidade medicamentosa, sugerindo uma reação adversa do tipo alérgico. Não há indicação de gravidade significativa ou desfecho conhecido, mas a suspeita de envolvimento imunológico reforça a necessidade de avaliação médica para diferenciar sinusite alérgica de outras causas e ajustar o tratamento conforme orientação

especializada.

O medicamento Fostair, que contém os princípios ativos beclometasona dipropionato e fumarato de formoterol, foi associado a um caso de sinusite, considerada aqui como uma possível manifestação de hipersensibilidade medicamentosa. Embora a gravidade não tenha sido explicitamente informada, a sinusite relacionada a medicamentos geralmente é classificada como de gravidade moderada, pois pode envolver sintomas como dor de cabeça, sensação de peso facial, secreção nasal e obstrução, exigindo avaliação médica para diferenciar entre causas alérgicas e infecciosas e para definir o tratamento adequado. Não há informações sobre o desfecho ou ação adotada neste caso, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O Montelukast, cujo princípio ativo é o montelucaste sódico, foi relacionado a um episódio de sinusite, interpretado como possível hipersensibilidade ao medicamento. A ausência de detalhes sobre a gravidade sugere que se trata de um quadro moderado, pois a sinusite pode causar desconforto significativo e requer avaliação médica para distinguir entre causas alérgicas e infecciosas, conforme orientações clínicas. Não há registro do desfecho ou das medidas tomadas, e a relação com o medicamento permanece suspeita.

O medicamento Alivium, composto por astemizol, paracetamol e cloridrato de fenilpropanolamina, foi associado a um caso de sinusite, considerada uma possível reação de hipersensibilidade medicamentosa. Não há especificação sobre a gravidade, mas, de acordo com a apresentação clínica típica da sinusite, pode-se considerar um quadro moderado, que exige avaliação médica para diferenciar entre causas alérgicas e infecciosas e para orientar o tratamento correto. O desfecho e as ações adotadas não foram informados, e a relação com o medicamento é suspeita.

O Spiriva, cujo princípio ativo é o brometo de tiotrópio, foi relacionado a um episódio de sinusite, interpretado como possível hipersensibilidade ao medicamento. A gravidade não foi detalhada, mas a sinusite, quando associada a medicamentos, costuma ser considerada moderada, pois pode envolver sintomas como dor facial, obstrução nasal e secreção, necessitando de avaliação médica para diagnóstico e tratamento adequados. Não há informações sobre o desfecho ou conduta, e a relação com o medicamento é suspeita.

A Dipirona, com princípio ativo metamizol sódico monoidratado, foi associada a um caso de sinusite, considerada uma possível manifestação de hipersensibilidade medicamentosa. Sem detalhes sobre a gravidade, assume-se um quadro moderado, pois a sinusite pode causar sintomas relevantes e requer avaliação médica para diferenciar entre causas alérgicas e infecciosas, conforme as recomendações clínicas. Não há dados sobre o desfecho ou medidas tomadas, e a relação com o medicamento é suspeita.

O medicamento Seretide, que contém os princípios ativos fluticasona propionato e salmeterol xinafoato, foi associado a um quadro de sinusite, considerado aqui como uma possível manifestação de hipersensibilidade medicamentosa. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave, e o desfecho do caso é desconhecido. A reação se enquadra em distúrbios do sistema imunitário, sugerindo que a sinusite pode ter relação com uma resposta alérgica ao medicamento, sendo importante avaliar clinicamente para diferenciar sinusite alérgica de infecciosa e definir a conduta adequada.

O uso de Amoxicilina + clavulanato de potássio (amoxicilina tri-hidratada e clavulanato de potássio) foi relacionado ao surgimento de sinusite, interpretada como uma possível reação de hipersensibilidade ao medicamento. Não há sinais de gravidade importante nem desfecho grave relatado, e o desfecho permanece desconhecido. A reação está classificada como distúrbio do sistema imunitário, o que sugere que a sinusite pode ter origem alérgica, sendo recomendada avaliação médica para diferenciar causas e evitar uso repetido do antibiótico sem necessidade.

O medicamento Nucala, cujo princípio ativo é mepolizumabe, foi associado ao desenvolvimento de sinusite, considerada uma possível reação de hipersensibilidade medicamentosa. Não há evidências de gravidade significativa ou desfecho grave, e o desfecho do caso não foi informado. A reação está relacionada a distúrbios do sistema imunitário, indicando que a sinusite pode ter componente alérgico, sendo importante acompanhamento

médico para avaliação e manejo adequado.

O uso de ciprofloxacino (ciprofloxacino hidrocloreto) resultou em um quadro de alergia, descrito como hipersensibilidade, sem sinais de gravidade relevante e com desfecho de recuperação completa. A reação foi classificada como distúrbio do sistema imunitário, sugerindo que o paciente apresentou uma resposta alérgica ao medicamento, sendo fundamental evitar nova exposição e informar o profissional de saúde sobre o episódio.

O medicamento Nactali, que contém desogestrel, foi relacionado ao aparecimento de sangue nas fezes, interpretado como possível manifestação de alergia ao leite, embora não haja confirmação de gravidade ou desfecho grave, e o desfecho seja desconhecido. A reação está enquadrada em distúrbios do sistema imunitário, sugerindo que pode haver relação com hipersensibilidade alimentar, sendo importante investigação clínica para esclarecer a causa e orientar o manejo.

O medicamento Micofenolato omicron, cujo princípio ativo é Mycophenolic acid, foi associado a um quadro de hipersensibilidade manifestado como nefrite lúpica, uma inflamação dos rins relacionada ao lúpus. A reação foi classificada como um distúrbio do sistema imunitário, mas não há indicação de gravidade elevada nem informações sobre o desfecho do caso. A relação entre o medicamento e a reação foi considerada suspeita, e não há detalhes sobre a conduta adotada ou evolução clínica.

Prednisona-, com princípio ativo Prednisone, foi relacionada a um episódio de hipersensibilidade apresentado como nefrite lúpica, que é uma inflamação renal associada ao lúpus. O evento foi categorizado como distúrbio do sistema imunitário, sem evidências de gravidade importante e sem informações sobre o desfecho. A suspeita de relação com o medicamento existe, mas não há dados sobre a conduta tomada ou evolução do quadro.

O medicamento Metilprednisolona, cujo princípio ativo é Methylprednisolone, esteve envolvido em um caso de hipersensibilidade manifestado como nefrite lúpica, uma inflamação dos rins relacionada ao lúpus. O evento foi classificado como distúrbio do sistema imunitário, não sendo considerado grave, e não há informações sobre o desfecho ou conduta adotada. A relação com o medicamento é suspeita, mas faltam detalhes adicionais.

Hidroxicloroquina, com princípio ativo Hydroxychloroquine, foi associada a um quadro de hipersensibilidade caracterizado por nefrite lúpica, que é uma inflamação renal decorrente do lúpus. O evento foi enquadrado como distúrbio do sistema imunitário, sem gravidade relevante relatada e sem informações sobre o desfecho ou medidas tomadas. A relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Imuran, cujo princípio ativo é Azathioprine, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade manifestado como nefrite lúpica, uma inflamação dos rins associada ao lúpus. O caso foi classificado como distúrbio do sistema imunitário, não sendo considerado grave, e não há informações sobre o desfecho ou conduta adotada. A relação com o medicamento é suspeita, mas não há detalhes adicionais disponíveis.

O medicamento Citalopram, cujo princípio ativo também é citalopram, foi associado a um quadro de nefrite lúpica, que é uma inflamação renal relacionada a uma reação de hipersensibilidade (alergia). Não há informação sobre gravidade clínica relevante ou desfecho do caso, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita. A conduta deve envolver avaliação médica para confirmação diagnóstica e acompanhamento, conforme orientações para quadros alérgicos medicamentosos.

O Marevan, que tem como princípio ativo o warfarin sódico, foi relacionado a um episódio de nefrite lúpica, caracterizando uma possível reação alérgica (hipersensibilidade) ao medicamento. Não há detalhes sobre gravidade ou evolução do quadro, e a suspeita de relação com o uso do medicamento foi registrada. Recomenda-se investigação clínica para confirmação e manejo adequado da reação.

O Benlysta, cujo princípio ativo é o belimumabe, foi associado a um caso de nefrite lúpica, sugerindo uma reação de hipersensibilidade (alergia) ao medicamento. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, e a relação



com o medicamento é considerada suspeita. É importante que o paciente seja avaliado por um especialista para confirmação e orientação do tratamento.

No caso da morfina (princípio ativo sulfato de morfina), foi relatada uma alergia documentada ao medicamento administrado, caracterizando uma reação de hipersensibilidade comprovada. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou evolução clínica, mas a relação com o medicamento foi considerada suspeita. Recomenda-se evitar novas exposições e buscar avaliação médica para manejo seguro.

O Kefazol, cujo princípio ativo é a cefazolina sódica, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), caracterizando uma reação alérgica ao medicamento. O caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente após a conduta adotada, que não foi detalhada. A relação com o medicamento foi considerada suspeita, e a evolução foi favorável.

O medicamento Dipirona, cujo princípio ativo é o metamizol sódico, foi associado ao surgimento de rubor, que é uma vermelhidão na pele decorrente de uma reação de hipersensibilidade (alergia). Não há informações sobre a gravidade clínica do caso, mas a ausência de indicação de gravidade e desfecho sugere que se trata de um quadro leve, compatível com manifestações alérgicas não graves. Recomenda-se observar o paciente, evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação médica caso haja recorrência ou piora dos sintomas.

A Norepinefrina, identificada pelo princípio ativo norepinephrine bitartrate, foi relacionada ao aparecimento de rubor, caracterizando uma reação de hipersensibilidade (alergia) leve, já que não há registro de gravidade ou desfecho grave. O quadro sugere uma manifestação alérgica não grave, sendo importante monitorar o paciente e evitar reexposição ao medicamento, além de procurar orientação médica se houver agravamento.

O medicamento Furosemida, com princípio ativo furosemida sódica, foi associado ao desenvolvimento de rubor, indicando uma reação de hipersensibilidade (alergia) leve, pois não há evidências de gravidade ou desfecho grave. Trata-se de uma manifestação alérgica não grave, recomendando-se evitar nova exposição ao fármaco e buscar avaliação médica caso os sintomas persistam ou se agravem.

O Paracetamol, cujo princípio ativo é o próprio paracetamol, foi relacionado ao surgimento de rubor, caracterizando uma reação de hipersensibilidade (alergia) leve, já que não há indicação de gravidade ou desfecho grave. O quadro sugere uma manifestação alérgica não grave, sendo importante evitar reexposição ao medicamento e procurar avaliação médica se houver recorrência ou piora dos sintomas.

O Bisacodil, com princípio ativo bisacodyl, foi associado ao aparecimento de rubor, indicando uma reação de hipersensibilidade (alergia) leve, pois não há registro de gravidade ou desfecho grave. Trata-se de uma manifestação alérgica não grave, sendo recomendado evitar nova exposição ao medicamento e buscar orientação médica caso os sintomas persistam ou se agravem.

O medicamento Enoxaparina, cujo princípio ativo é enoxaparin sodium, foi associado ao surgimento de rubor, que é uma manifestação de hipersensibilidade (alergia) caracterizada por vermelhidão na pele. Essa reação está relacionada a quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada nem de desfecho grave, e o desfecho do caso é desconhecido. A conduta recomendada, conforme diretrizes clínicas, é observar a evolução dos sintomas e buscar avaliação médica caso haja piora ou aparecimento de outros sinais de alergia.

A amitriptilina, cujo princípio ativo é amitriptyline hydrochloride, foi relacionada ao aparecimento de rubor, uma reação de hipersensibilidade (alergia) que se manifesta como vermelhidão na pele. Essa resposta faz parte dos quadros clínicos alérgicos e envolve o sistema imunitário. Não há evidências de gravidade importante ou desfecho grave, e o desfecho permanece desconhecido. Recomenda-se monitorar os sintomas e procurar avaliação médica se houver agravamento ou surgimento de outros sinais alérgicos.

O medicamento fludrocortisona, com princípio ativo fludrocortisone, foi associado ao desenvolvimento de rubor, que é uma manifestação de hipersensibilidade (alergia) caracterizada por vermelhidão cutânea. Essa reação está inserida nos quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade significativa nem de desfecho grave, sendo o desfecho desconhecido. A orientação é observar a evolução e buscar avaliação médica caso haja piora ou outros sintomas de alergia.

O clonazepam, cujo princípio ativo é clonazepam, foi relacionado ao surgimento de rubor, uma reação de hipersensibilidade (alergia) que se apresenta como vermelhidão na pele. Essa manifestação faz parte dos quadros clínicos alérgicos e envolve o sistema imunitário. Não há sinais de gravidade relevante ou desfecho grave, e o desfecho é desconhecido. Recomenda-se acompanhamento dos sintomas e avaliação médica se houver agravamento ou outros sinais alérgicos.

A gabapentina, com princípio ativo gabapentin, foi associada ao aparecimento de rubor, que é uma manifestação de hipersensibilidade (alergia) caracterizada por vermelhidão na pele. Essa reação está relacionada a quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade importante nem de desfecho grave, sendo o desfecho desconhecido. A conduta recomendada é observar a evolução dos sintomas e procurar avaliação médica caso haja piora ou outros sinais de alergia.

O medicamento Meropenem, cujo princípio ativo também é Meropenem, foi associado a um quadro de rubor, interpretado como uma reação de hipersensibilidade (alergia), pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada nem de desfecho conhecido, sugerindo que a reação foi leve e não houve evolução grave ou complicações relatadas. A conduta recomendada é observar o paciente, evitar novas exposições ao medicamento e buscar avaliação médica caso haja recorrência ou agravamento dos sintomas.

O medicamento Infliximab, com princípio ativo de mesmo nome, foi utilizado em situação não descrita na bula (off label) e resultou em uma reação de hipersensibilidade (alergia), classificada como clinicamente significativa e grave, pois o evento não foi resolvido até o momento. O caso envolve distúrbios do sistema imunitário e requer acompanhamento médico rigoroso, com suspensão do uso do medicamento e monitoramento contínuo, já que o paciente permanece em evolução sem recuperação.

O medicamento 6-mercaptopurine monohydrate, cujo princípio ativo é Mercaptopurine, foi utilizado fora das indicações da bula (off label) e desencadeou uma reação de hipersensibilidade (alergia), considerada clinicamente significativa e grave, pois o paciente não apresentou resolução do quadro até o momento. Trata-se de um distúrbio do sistema imunitário que exige suspensão do medicamento e acompanhamento médico próximo, já que o evento permanece em andamento.

O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é Tozinameran, foi administrado em uso não descrito na bula (off label) e resultou em uma reação de hipersensibilidade (alergia), classificada como clinicamente significativa e grave, pois o paciente não se recuperou até o momento. O quadro envolve distúrbios do sistema imunitário e demanda suspensão do uso, além de acompanhamento médico contínuo devido à persistência dos sintomas.

O medicamento Erbitux, com princípio ativo Cetuximab, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como clinicamente significativo e grave, mas com desfecho favorável, pois o paciente se recuperou totalmente. O evento envolveu distúrbios do sistema imunitário e, diante da gravidade, a conduta adequada foi a suspensão do medicamento e monitoramento até a resolução completa dos sintomas.

O medicamento Dexchlorpheniramine maleate, cujo princípio ativo é o próprio Dexchlorpheniramine maleate, foi associado a um quadro de hipersensibilidade, manifestando-se como imunossupressão, ou seja, uma redução da resposta do sistema imunológico. A reação foi classificada como não grave, pois não há indicação de gravidade clínica relevante no registro, e o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente. Não há informações adicionais sobre a conduta adotada, mas o caso foi resolvido sem complicações.

O medicamento Aciclovir, com princípio ativo Aciclovir, esteve relacionado a um episódio de hipersensibilidade caracterizado por imunossupressão, que significa uma diminuição da atividade do sistema imunológico. A reação não foi considerada grave, conforme evidenciado pela ausência de sinais de gravidade clínica, e o paciente se recuperou totalmente. Não há detalhes sobre intervenções específicas, mas o evento foi resolvido sem consequências duradouras.

O medicamento Corticosteroid nos, cujo princípio ativo não foi especificado além da classe corticosteroide, foi associado a uma reação de hipersensibilidade manifestada como imunossupressão, ou seja, uma diminuição da resposta imunológica. O evento não foi considerado grave, pois não há indícios de gravidade clínica, e o paciente apresentou recuperação completa. Não há informações adicionais sobre a conduta, mas o desfecho foi resolutivo.

O medicamento Ketamine, com princípio ativo Ketamine, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade, manifestando-se como imunossupressão, que é a redução da atividade do sistema imunológico. A reação não foi classificada como grave, já que não há evidências de gravidade clínica, e o paciente se recuperou totalmente. Não há detalhes sobre medidas tomadas, mas o caso foi resolvido sem complicações.

O medicamento Vitamina D, cujo princípio ativo é o Colecalciferol, esteve associado a uma reação de hipersensibilidade caracterizada por imunossupressão, ou seja, uma diminuição da resposta do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave, pois não há sinais de gravidade clínica, e o paciente se recuperou completamente. Não há informações sobre intervenções específicas, mas o desfecho foi favorável.

O medicamento Alemtuzumab, cujo princípio ativo também é alemtuzumab, foi associado a um quadro de hipersensibilidade caracterizado por imunossupressão, o que indica uma reação alérgica do tipo distúrbio do sistema imunitário. Não há menção de gravidade clínica relevante neste caso, e o paciente evoluiu para recuperação completa, sugerindo que a reação foi leve e adequadamente manejada.

O medicamento Carvedilol, com princípio ativo carvedilol, esteve relacionado ao desenvolvimento de erisipela, uma infecção cutânea que, neste contexto, foi considerada uma manifestação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imune. A gravidade do caso é evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando um evento adverso grave, mas o paciente encontra-se em recuperação, mostrando resposta positiva ao tratamento.

O medicamento Besilato de anlodipino, cujo princípio ativo é amlodipina besilato, foi associado ao surgimento de erisipela, interpretada como uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade envolvendo o sistema imunológico. O caso foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, mas o paciente está em processo de recuperação, indicando evolução favorável após a conduta médica.

O medicamento Benicar, com princípio ativo olmesartan medoxomil, foi relacionado ao aparecimento de erisipela, uma infecção de pele que, neste contexto, representa uma reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imune. O evento foi classificado como grave devido à hospitalização ou prolongamento da internação, mas o paciente está em recuperação, sugerindo que a conduta adotada foi eficaz.

O medicamento Vectibix, cujo princípio ativo é panitumumabe, esteve associado ao desenvolvimento de erisipela, considerada uma manifestação de hipersensibilidade do sistema imunológico. O caso foi considerado grave, pois exigiu hospitalização ou prolongamento da internação, mas o paciente está em recuperação, indicando resposta positiva ao tratamento instituído.

O medicamento Ribociclib, cujo princípio ativo também é Ribociclib, foi associado a um quadro de hipersensibilidade, caracterizado como uma reação alérgica do sistema imunológico. A descrição sugere um quadro clínico alérgico inespecífico, sem detalhamento de sintomas graves ou risco imediato, e não há evidência de gravidade aumentada, pois o caso não foi classificado como grave. O desfecho indica que a reação ainda está em andamento ou não resolvida, sendo importante acompanhamento clínico para monitorar a evolução e

considerar avaliação especializada caso haja piora.

O medicamento Fexofenadine, com princípio ativo Fexofenadine, foi relacionado a um episódio de alergia alimentar, que é uma resposta do sistema imunológico a determinados alimentos, embora não haja detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade. O evento não foi considerado grave e o desfecho permanece desconhecido, o que reforça a necessidade de observação clínica e investigação de possíveis gatilhos alimentares, sem indicação de risco imediato.

O medicamento Dprev, cujo princípio ativo é Colecalciferol, foi associado a um relato de alergia alimentar, indicando uma possível reação imunológica a alimentos, mas sem descrição de sintomas específicos ou sinais de gravidade. O caso não foi classificado como grave e o desfecho é desconhecido, sugerindo que a conduta deve ser de observação e investigação clínica, sem necessidade de medidas emergenciais no momento.

O medicamento Dupilumab, com princípio ativo Dupilumab, foi relacionado a um quadro de alergia alimentar, caracterizando uma reação do sistema imunológico a alimentos, sem detalhamento de sintomas ou gravidade. Não há indicação de gravidade aumentada e o desfecho é desconhecido, sendo recomendada a observação clínica e investigação de possíveis fatores desencadeantes, sem sinais de risco imediato.

O medicamento Fexofenadine, cujo princípio ativo é Fexofenadine, foi associado a alergias múltiplas, sugerindo manifestações alérgicas diversas do sistema imunológico, mas sem especificação de sintomas ou gravidade. O caso não foi considerado grave e o desfecho permanece desconhecido, indicando que a conduta deve ser de acompanhamento clínico e investigação das possíveis causas, sem necessidade de intervenção urgente.

O medicamento Dprev, cujo princípio ativo é o colecalciferol, foi associado a um distúrbio da tireoide (SOE) em um paciente com histórico de alergias múltiplas. A reação foi classificada como relacionada a quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário, mas não há indicação de gravidade elevada nem de desfecho conhecido, sugerindo que o evento não foi grave e que a evolução do quadro permanece incerta.

O medicamento Dupilumab, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um distúrbio da tireoide (SOE) em contexto de alergias múltiplas. A reação se enquadra em quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário, sem evidências de gravidade significativa e sem desfecho informado, indicando que o evento não foi considerado grave e o resultado final não está documentado.

A difenidramina (princípio ativo diphenhydramine hydrochloride) foi associada a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como reação alérgica do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade relevante, e o paciente se recuperou totalmente após o evento, indicando resolução completa do quadro sem complicações.

O uso de hidrocortisona (princípio ativo hydrocortisone) resultou em uma reação alérgica (hipersensibilidade), caracterizada como um quadro clínico alérgico do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação total, demonstrando resolução do quadro sem consequências duradouras.

O medicamento Sarclisa, cujo princípio ativo é o isatuximab, foi relacionado a uma reação alérgica (hipersensibilidade), enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Não houve gravidade significativa e o paciente se recuperou completamente, indicando que a reação foi resolvida sem complicações.

O medicamento Difenidrin, cujo princípio ativo é o cloridrato de difenidramina, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, que se manifesta como uma reação do sistema imunológico ao medicamento. Não há indicação de gravidade aumentada ou complicações clínicas relevantes neste caso, e a reação foi classificada como não grave, sem informações adicionais sobre desfecho ou conduta adotada.

A hidrocortisona, identificada pelo princípio ativo hydrocortisone, foi relacionada a um episódio de alergia do tipo hipersensibilidade, sugerindo uma resposta imunológica adversa ao medicamento. Não há evidências de gravidade

significativa ou complicações associadas, sendo a reação considerada não grave, e não foram fornecidos detalhes sobre evolução clínica ou medidas tomadas.

O medicamento Bavencio, cujo princípio ativo é avelumabe, foi implicado em um caso de alergia descrito como hipersensibilidade, indicando uma reação imunológica ao uso do produto. Não há sinais de gravidade aumentada ou complicações clínicas, sendo a reação considerada não grave, e não há informações adicionais sobre desfecho ou conduta.

A hidrocortisona (hydrocortisone) foi associada ao desenvolvimento de edema palpebral, que é o inchaço das pálpebras, relacionado a uma hipersensibilidade documentada ao produto administrado. A descrição sugere um erro ou problema de monitoramento do medicamento, mas não há informações suficientes para afirmar gravidade ou detalhar a evolução clínica, nem sobre as medidas adotadas.

O medicamento Buscopan composto, contendo butilbrometo de escopolamina e metamizol sódico, foi relacionado ao surgimento de edema palpebral, caracterizado por inchaço nas pálpebras devido a hipersensibilidade documentada ao produto. O evento está associado a um problema de monitoramento do uso do medicamento, mas não há dados suficientes para determinar a gravidade ou descrever a evolução clínica e conduta.

O medicamento Levofloxacino (princípio ativo: Levofloxacin) foi prescrito apesar de haver uma contraindicação documentada por hipersensibilidade ao produto, o que caracteriza um erro de monitoramento e pode resultar em reações adversas graves, como alergias ou outras complicações. Não há detalhes sobre a gravidade clínica ou desfecho, mas a prescrição de um medicamento contraindicado por alergia exige suspensão imediata do uso e avaliação médica para evitar riscos maiores.

A Dexclorfeniramina (princípio ativo: Dexchlorpheniramine) foi associada a um caso de DILI (lesão hepática induzida por medicamento) em paciente com hipersensibilidade documentada ao produto, indicando um erro de monitoramento. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, mas a administração de um medicamento a que o paciente é alérgico pode causar reações adversas importantes, sendo fundamental interromper o uso e buscar avaliação médica.

A Amoxicilina (princípio ativo: Amoxicillin sodium) foi relacionada a um caso de DILI (lesão hepática induzida por medicamento) em paciente com hipersensibilidade documentada ao produto, o que representa um erro de monitoramento e pode resultar em reações adversas graves. Não há detalhes sobre a evolução clínica, mas a administração de amoxicilina em paciente alérgico deve ser evitada e, caso ocorra, o medicamento deve ser suspenso imediatamente e o paciente avaliado por um especialista.

O Cetoprofeno (princípio ativo: Ketoprofen) foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), sem detalhamento de sintomas ou gravidade. A reação foi classificada como distúrbio do sistema imunitário, sugerindo manifestação alérgica, e não há informações sobre o desfecho. Em casos de suspeita de alergia a anti-inflamatórios, recomenda-se suspender o uso e procurar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação adequada.

O medicamento Brilinta (princípio ativo: Ticagrelor) foi relacionado a um ataque cardíaco em contexto de hipersensibilidade medicamentosa, mas não há informações suficientes para afirmar gravidade, já que o evento foi classificado como não grave e o paciente permanece não recuperado ou em andamento. A relação entre ataque cardíaco e alergia ao medicamento deve ser cuidadosamente avaliada por equipe médica, com monitoramento contínuo e ajuste do tratamento conforme evolução clínica.

O medicamento Rocefin, cujo princípio ativo é o ceftriaxona sódica, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como um distúrbio do sistema imunitário. A reação foi considerada leve, pois não há indicação de gravidade aumentada ou complicações, e o desfecho foi de recuperação completa. Nestes casos, recomenda-se evitar novas exposições ao medicamento e buscar avaliação com alergista para confirmação

diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

No caso do Noripurum, que contém como princípio ativo o complexo de hidróxido férrico polimaltoisado, foi relatada a prescrição de um produto contraindicado devido à hipersensibilidade documentada ao mesmo. Trata-se de um erro de prescrição, e não há informações sobre gravidade ou desfecho. A conduta adequada é suspender imediatamente o uso do medicamento e garantir que o histórico de alergia seja considerado em futuras prescrições, além de encaminhar para avaliação especializada se necessário.

O medicamento Ezobloc, cujo princípio ativo é o esomeprazol magnésico, foi relacionado a uma crise asmática, descrita como manifestação de alergia sazonal (distúrbio atópico). Não há indicação de gravidade aumentada ou complicações graves, e o quadro permanece em andamento, sem resolução até o momento. Recomenda-se procurar avaliação médica para confirmação do diagnóstico, identificação de possíveis desencadeantes e ajuste do tratamento, conforme orientações para casos de asma associada a alergias.

O Moduretic, que contém amilorida hidrocloreídrica e hidroclorotiazida, foi associado a uma crise asmática, classificada como manifestação de alergia sazonal (distúrbio atópico). Não há sinais de gravidade aumentada, e o quadro segue sem resolução. A orientação é buscar avaliação médica para investigar a relação entre o medicamento e a crise, identificar fatores desencadeantes e ajustar o tratamento da asma conforme necessário.

O medicamento Synthroid, cujo princípio ativo é a levotiroxina sódica, foi relacionado a uma crise asmática, descrita como manifestação de alergia sazonal (distúrbio atópico). Não há evidências de gravidade aumentada, e o quadro permanece em andamento, sem resolução. Recomenda-se avaliação médica para confirmar o diagnóstico, investigar possíveis gatilhos e ajustar o manejo da asma conforme as diretrizes clínicas.

O medicamento Xolair, cujo princípio ativo é o Omalizumabe, foi associado a uma crise asmática em um paciente com histórico de alergia sazonal, dentro do contexto de distúrbios do sistema imunitário. Embora não haja indicação de gravidade elevada ou desfecho resolvido, a reação permanece em andamento, o que sugere a necessidade de acompanhamento clínico para controle dos sintomas e ajuste do tratamento, conforme as diretrizes para asma e alergias respiratórias.

O medicamento Glifage, que contém Metformina como princípio ativo, foi relacionado a um episódio de COVID-19 em paciente com alergia ao leite, sendo classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Não há informações suficientes para determinar a gravidade ou o desfecho do caso, e não é possível afirmar uma relação causal direta entre o uso do medicamento e o evento relatado, sendo importante manter o acompanhamento clínico.

O medicamento Berotec, cujo princípio ativo é o bromidrato de fenoterol, foi associado a um episódio de COVID-19 em paciente com alergia ao leite, dentro do contexto de distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhes sobre gravidade ou desfecho, e a relação entre o uso do medicamento e o evento permanece apenas como suspeita, sendo recomendada a observação clínica e avaliação médica conforme evolução dos sintomas.

O medicamento Tandrilax, composto por cafeína, carisoprodol, diclofenaco sódico e paracetamol, foi relacionado a um caso de edema de glote, que é um quadro de hipersensibilidade aguda e potencialmente grave, caracterizado por inchaço súbito na região da garganta. O desfecho informado foi de recuperação completa, indicando resolução do quadro após a conduta adotada, que deve ter incluído medidas de suporte e suspensão do medicamento, conforme recomendações para reações alérgicas agudas.

O medicamento Dramin, cujo princípio ativo é o dimenidrinato, foi prescrito a um paciente com hipersensibilidade documentada ao produto, configurando um erro de prescrição. Não há informações sobre a ocorrência de reação adversa ou desfecho, mas a conduta correta seria evitar a administração e buscar alternativas seguras, reforçando a importância da checagem prévia de alergias antes da prescrição.

O medicamento Gadobutrol, cujo princípio ativo também é gadobutrol, foi associado a um quadro de alergia a contraste, reação que envolve o sistema imunológico e pode se manifestar por sintomas como coceira, urticária ou desconforto respiratório após a administração do contraste. Neste caso, a reação foi considerada não grave, pois o paciente se recuperou completamente, e não há menção de complicações ou necessidade de intervenções emergenciais. A conduta recomendada é sempre informar a equipe médica sobre qualquer histórico de alergia a contraste antes de novos exames, para que medidas preventivas possam ser adotadas.

O medicamento Buscopan composto, que contém hyoscine butylbromide e metamizole sodium, foi relacionado ao surgimento de tremor, interpretado como uma reação de hipersensibilidade ao produto administrado. Não há informações suficientes sobre a gravidade, desfecho ou conduta adotada neste caso, mas é importante ressaltar que qualquer sintoma inesperado após o uso de medicamentos deve ser comunicado ao médico para avaliação e orientação adequada.

O medicamento Iopromida, cujo princípio ativo é iopromide, foi associado a um episódio de alergia a contraste, uma reação imunológica que pode ocorrer após a exposição a substâncias usadas em exames de imagem. Neste caso, a reação não foi considerada grave, pois o paciente se recuperou totalmente, e não há relato de complicações adicionais. Recomenda-se informar sempre sobre alergias prévias a contraste antes de novos procedimentos para garantir a segurança do paciente.

O medicamento Iopromida, com princípio ativo iopromide, esteve envolvido em um caso de alergia a contraste, caracterizada por uma resposta do sistema imunológico após a administração do produto. O paciente encontra-se em recuperação, sem informações de gravidade elevada ou complicações graves, sugerindo um quadro de evolução favorável. É fundamental relatar qualquer reação anterior a contraste ao médico antes de novos exames para prevenir recorrências.

O medicamento Iopromida, cujo princípio ativo é iopromide, foi relacionado a uma reação de alergia a contraste, que envolve o sistema imunológico e pode causar sintomas como coceira, vermelhidão ou desconforto respiratório. O paciente está em processo de recuperação, sem indicação de gravidade importante ou complicações, o que sugere um quadro controlado. Sempre que houver histórico de alergia a contraste, é essencial comunicar a equipe médica antes de novos procedimentos para garantir a adoção de medidas preventivas.

O medicamento Atorvastatina, cujo princípio ativo é atorvastatina, foi associado ao surgimento de pápulas, um tipo de lesão de pele que pode indicar uma reação de hipersensibilidade (alergia). Não há indicação de gravidade elevada, pois o quadro está em recuperação e não foi considerado grave, sugerindo uma manifestação leve e autolimitada. A conduta recomendada é observar a evolução dos sintomas, evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas terapêuticas.

O medicamento Ramipril, com princípio ativo ramipril, foi relacionado ao aparecimento de pápulas, caracterizando uma reação de hipersensibilidade (alergia) de intensidade leve, já que não foi considerada grave e o paciente encontra-se em recuperação. Recomenda-se suspender o uso do medicamento suspeito, monitorar a evolução dos sintomas e procurar avaliação médica para confirmação do diagnóstico e definição do melhor tratamento.

O medicamento Succinato de desvenlafaxina monohidratado, cujo princípio ativo é desvenlafaxina succinate monohydrate, foi associado ao surgimento de pápulas, indicando uma reação de hipersensibilidade (alergia) leve, pois não foi considerada grave e o paciente está em recuperação. A orientação é evitar nova exposição ao medicamento, observar a evolução clínica e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e ajuste do tratamento.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é iopromida, foi relacionado a uma reação anafilática, que é uma forma grave de alergia a contraste iodado. A gravidade é confirmada pela classificação como clinicamente significativa e grave, sendo uma situação que exige atendimento médico imediato devido ao risco de complicações sérias. O desfecho é desconhecido, portanto é fundamental garantir acompanhamento médico e evitar futuras

exposições ao contraste.

O medicamento Hydrochlorothiazide, com princípio ativo hydrochlorothiazide, foi associado a uma erupção cutânea, caracterizando uma reação de hipersensibilidade medicamentosa (alergia) de intensidade leve, já que não foi considerada grave e o paciente já se recuperou totalmente. Recomenda-se evitar nova exposição ao medicamento e informar o médico sobre o episódio para orientar futuras prescrições.

O medicamento Actemra (princípio ativo: Tocilizumab) foi associado a uma reação de erupção na pele, caracterizada como hipersensibilidade medicamentosa, um tipo de alergia que envolve o sistema imunológico. Neste caso, a reação não foi considerada grave e o paciente se recuperou completamente após o evento, não havendo necessidade de hospitalização ou intervenção adicional. A conduta recomendada é observar possíveis recorrências e, caso ocorram sintomas semelhantes, buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre o uso futuro do medicamento.

O medicamento Rosuvastatina (princípio ativo: Rosuvastatin) provocou rubor facial, identificado como uma manifestação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico ao medicamento. A gravidade do caso foi evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando que a reação exigiu cuidados médicos mais intensivos. Apesar disso, o paciente se recuperou totalmente após o episódio. Em situações como essa, é fundamental evitar a reexposição ao medicamento e discutir alternativas terapêuticas com o médico responsável.

A Levotiroxina (princípio ativo: Levothyroxine) foi relacionada a um episódio de rubor facial, interpretado como hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta alérgica do organismo ao medicamento. O caso foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que demonstra a importância de monitoramento médico rigoroso nessas situações. O paciente evoluiu para recuperação completa, e recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento sem orientação médica especializada.

O medicamento Tevaoxali (princípio ativo: Oxaliplatin) desencadeou rubor facial, caracterizado como hipersensibilidade medicamentosa, uma reação alérgica do sistema imunológico. A gravidade foi confirmada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando que a reação exigiu atenção médica imediata. O paciente se recuperou totalmente após o evento, e é importante que futuras exposições ao medicamento sejam avaliadas cuidadosamente por um especialista.

O medicamento Ultravist (princípio ativo: Iopromide) foi associado a um quadro de alergia, classificado como hipersensibilidade, que é uma reação do sistema imunológico ao contato com o medicamento. Neste caso, a reação não foi considerada grave e o paciente se recuperou completamente após o episódio, não havendo necessidade de hospitalização. Recomenda-se atenção a possíveis reações futuras e avaliação médica antes de novas exposições ao contraste.

O medicamento Metoclopramida, cujo princípio ativo é Metoclopramide, foi associado a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica específica ao remédio. Não há informação sobre gravidade clínica relevante ou desfecho do caso, e o registro indica que não foi considerada uma reação grave. A suspeita de alergia medicamentosa deve sempre ser avaliada por um profissional de saúde, especialmente para evitar novas exposições ao fármaco.

O contraste Iopromide, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a uma reação alérgica ao contraste, caracterizada como hipersensibilidade a substâncias químicas. O caso evoluiu para recuperação completa, sem indicação de gravidade elevada, e a reação foi considerada resultado de uma interação. Em situações de alergia a contraste, é fundamental informar a equipe médica antes de novos exames para prevenir reações futuras.

O medicamento Metoclopramid, com princípio ativo Metoclopramide, foi associado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica ao remédio. Não há detalhes sobre gravidade ou



desfecho, mas o evento não foi considerado grave. Em casos de suspeita de alergia medicamentosa, recomenda-se evitar o uso do medicamento até avaliação médica adequada.

A Dipirona, cujo princípio ativo é Metamizole sodium, foi relacionada a um quadro de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica ao medicamento. O caso evoluiu para recuperação completa, sem indicação de gravidade relevante. Em situações de alergia a dipirona, é importante evitar novas exposições e buscar orientação médica para alternativas seguras.

O medicamento Cetoprofeno, com princípio ativo Ketoprofen sodium, foi associado a um episódio de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica ao remédio. O desfecho foi de recuperação completa e não há evidência de gravidade significativa. Em casos de alergia a anti-inflamatórios como o cetoprofeno, recomenda-se evitar o uso e consultar um especialista para avaliação e orientação.

O medicamento Cefazolina (princípio ativo: Cefazolin sodium) foi associado a um quadro de alergia, descrito como hipersensibilidade, que se enquadra nos distúrbios do sistema imunitário. Não há informação explícita sobre gravidade aumentada ou risco de vida, e o desfecho foi de recuperação completa, sugerindo um evento leve a moderado, compatível com reações alérgicas comuns a antibióticos, que geralmente requerem suspensão do medicamento e acompanhamento médico para evitar recorrências.

O medicamento Levothyroxine sodium (princípio ativo: Levothyroxine sodium) foi relacionado a um quadro de hipoglicemia neonatal, com suspeita de alergia ao leite, classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou risco de vida, e o caso permanece em andamento sem resolução até o momento, o que reforça a necessidade de acompanhamento clínico para investigação da causa e manejo adequado, especialmente em recém-nascidos.

O medicamento Henetix (princípio ativo: Iobitridol) foi associado a uma reação alérgica ao contraste, considerada uma situação de ameaça à vida, evidenciada pela gravidade informada e pelo desfecho de recuperação com sequelas. Reações alérgicas graves a contraste iodado podem evoluir rapidamente e exigem intervenção médica imediata, sendo fundamental o monitoramento rigoroso e a prevenção em futuras exposições.

O medicamento Alemtuzumab (princípio ativo: Alemtuzumab) foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade, classificado como distúrbio do sistema imunitário, sem indicação de gravidade aumentada ou risco de vida, e com desfecho de recuperação completa, sugerindo uma reação alérgica leve a moderada, que geralmente é manejada com suspensão do agente e suporte clínico.

O medicamento Henetix (princípio ativo: Iobitridol) foi associado a um episódio de alergia, descrito como hipersensibilidade, sem evidência de gravidade aumentada ou risco de vida, e com recuperação completa do paciente. Esse tipo de reação, quando leve, costuma ser resolvido com a interrupção do uso do contraste e acompanhamento médico para evitar novas exposições.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o Iopromide, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação do sistema imunológico após o uso do contraste. A reação foi considerada não grave, pois o paciente se recuperou completamente, e não há relato de complicações ou necessidade de intervenção médica urgente. O evento foi resolvido, indicando que a conduta adotada foi suficiente para o controle da reação alérgica.

O medicamento Anastrozole, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um evento descrito como metástases em ossos, mas classificado sob hipersensibilidade (alergia) no sistema imunológico. Não há informações suficientes para detalhar a gravidade ou a conduta adotada, e o desfecho permanece desconhecido, impossibilitando uma avaliação mais precisa da evolução clínica.

O Letrozole, cujo princípio ativo também é Letrozole, foi associado a um evento de metástases em ossos, categorizado como hipersensibilidade (alergia) no sistema imunológico. Não há detalhes sobre a gravidade, conduta ou evolução do caso, e o desfecho é desconhecido, não permitindo afirmar se houve resolução ou complicações.

O medicamento Kisqali, com princípio ativo Ribociclib succinate, foi relacionado a um evento de metástases em ossos, classificado como hipersensibilidade (alergia) no sistema imunológico. Não há informações sobre a gravidade, conduta adotada ou evolução clínica, e o desfecho é desconhecido, o que limita a análise do caso.

O medicamento Iopromida, cujo princípio ativo é Iopromide, foi associado a uma alergia a contraste, caracterizada por uma reação do sistema imunológico após exposição ao agente de contraste. O evento não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou totalmente, e não há relato de complicações adicionais, indicando que a conduta adotada foi eficaz para resolução da reação.

O medicamento Dexamethasone (princípio ativo: Dexamethasone) foi associado a um quadro de pseudorrecidiva de esclerose múltipla, caracterizado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. Essa reação se enquadra nos distúrbios do sistema imunitário e foi considerada grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, conforme evidenciado pelo registro clínico. O desfecho relatado foi de não recuperação ou resolução até o momento, indicando que o quadro permanece em andamento.

O medicamento Morphine (princípio ativo: Morphine) esteve relacionado a uma pseudorrecidiva de esclerose múltipla, descrita como hipersensibilidade medicamentosa. Trata-se de uma reação imunológica relevante, classificada como grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, conforme evidência clínica disponível. O desfecho informado foi de não recuperação ou resolução, indicando que o paciente segue em acompanhamento para o evento adverso.

O medicamento Morphine (princípio ativo: Morphine) foi novamente associado a uma pseudorrecidiva de esclerose múltipla, caracterizada como hipersensibilidade medicamentosa. A gravidade do caso é sustentada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando um impacto clínico importante. O desfecho permanece não resolvido, com o paciente ainda em evolução clínica.

O medicamento Tysabri (princípio ativo: Natalizumab) foi relacionado a uma pseudorrecidiva de esclerose múltipla, identificada como hipersensibilidade medicamentosa. O evento foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, conforme registro clínico. O desfecho relatado indica que o quadro não foi resolvido até o momento, permanecendo em acompanhamento.

O medicamento Dipropionato de betametasona + fosfato dissódico de betametasona (princípios ativos: Betamethasone dipropionate e Betamethasone sodium phosphate) foi associado a um quadro de alergia, descrito como hipersensibilidade. Embora não haja detalhamento sobre a gravidade, o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente após a reação, sugerindo resolução do quadro alérgico.

O medicamento Clonazepam, cujo princípio ativo também é Clonazepam, foi associado a um episódio de hemorragia da garganta, caracterizado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. Essa manifestação indica uma resposta alérgica significativa do sistema imunológico, classificada como clinicamente relevante devido ao potencial risco à saúde, conforme evidenciado pela gravidade registrada como 'outro efeito clinicamente significativo' e a marcação de gravidade como 'Sim'. O paciente evoluiu para recuperação completa após a reação, sugerindo que as medidas adotadas foram eficazes para resolução do quadro.

O medicamento Clonazepam, com princípio ativo Clonazepam, esteve relacionado a um caso de hemorragia da garganta, interpretado como hipersensibilidade medicamentosa. Trata-se de uma reação alérgica relevante do sistema imunológico, considerada grave devido ao potencial impacto clínico, conforme indicado pela classificação de gravidade e a confirmação de gravidade importante. O desfecho foi favorável, com recuperação total do

paciente após o evento.

O medicamento Fluoxetine hydrochloride, cujo princípio ativo é o mesmo, foi implicado em um episódio de hemorragia da garganta, identificado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. Essa resposta alérgica do sistema imunológico foi considerada clinicamente significativa, com gravidade confirmada, o que reforça a necessidade de atenção médica imediata em casos semelhantes. O paciente se recuperou totalmente após o evento, indicando resolução do quadro após a conduta adotada.

O medicamento Fluoxetine hydrochloride, com princípio ativo Fluoxetine hydrochloride, esteve envolvido em um caso de hemorragia da garganta, classificado como hipersensibilidade medicamentosa. A reação foi considerada clinicamente relevante e grave, evidenciando a importância de monitoramento rigoroso em pacientes que apresentam sintomas alérgicos após o uso do medicamento. O desfecho foi positivo, com recuperação completa do paciente.

O medicamento Carbamazepine, cujo princípio ativo é Carbamazepine, foi associado a um episódio de hemorragia da garganta, interpretado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. Essa resposta alérgica do sistema imunológico foi considerada clinicamente significativa e grave, justificando a necessidade de intervenção médica imediata. O paciente apresentou recuperação total após o evento, indicando resolução adequada do quadro.

O medicamento Losartana potássica (princípio ativo: Losartan potassium) foi associado a um episódio de hemorragia da garganta, caracterizado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. Esse evento é considerado clinicamente significativo e grave, conforme evidenciado pela classificação do caso, e está relacionado a distúrbios do sistema imunitário. O paciente se recuperou totalmente após o episódio, indicando resolução do quadro após a conduta adequada.

O uso de Atenolol (princípio ativo: Atenolol) resultou em hemorragia da garganta, identificada como uma reação de hipersensibilidade ao medicamento. Trata-se de um efeito clinicamente relevante e grave, relacionado a distúrbios do sistema imunitário, conforme a categorização do evento. O paciente evoluiu para recuperação completa após o episódio, demonstrando resolução do quadro após as medidas tomadas.

O medicamento Diphenhydramine hydrochloride (princípio ativo: Diphenhydramine hydrochloride) foi relacionado a um caso de hemorragia da garganta, interpretado como hipersensibilidade medicamentosa. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, estando associado a distúrbios do sistema imunitário. O paciente apresentou recuperação total após o episódio, indicando resolução do quadro após a conduta apropriada.

Diphenhydramine hydrochloride (princípio ativo: Diphenhydramine hydrochloride) esteve envolvido em um episódio de hemorragia da garganta, caracterizado como reação de hipersensibilidade ao medicamento. O caso foi classificado como clinicamente significativo e grave, relacionado a distúrbios do sistema imunitário. O paciente se recuperou completamente após o evento, evidenciando resolução do quadro após as medidas adotadas.

O medicamento Tysabri (princípio ativo: Natalizumab) foi associado a hemorragia da garganta, interpretada como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, relacionado a distúrbios do sistema imunitário. O paciente apresentou recuperação total após o episódio, indicando resolução do quadro após a conduta adequada.

O medicamento Tysabri (Natalizumab) foi associado a um episódio de hemorragia na garganta, caracterizado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico ao fármaco. A gravidade do evento é considerada clinicamente significativa, pois envolveu manifestação importante e potencialmente grave, conforme registrado. O paciente se recuperou totalmente após o episódio, indicando resolução do quadro após a conduta médica adequada.

O medicamento Henetix (lobitridol) provocou uma reação alérgica ao contraste, que é uma resposta imunológica adversa ao agente utilizado em exames de imagem. O evento foi considerado clinicamente significativo devido à gravidade relatada, exigindo atenção médica imediata. O paciente encontra-se em processo de recuperação, demonstrando evolução favorável após a identificação e manejo da reação.

O medicamento Henetix (lobitridol) desencadeou um quadro de alergia, tecnicamente chamado de hipersensibilidade, que corresponde a uma reação do sistema imunológico ao medicamento. Neste caso, a reação não foi considerada grave e o paciente se recuperou completamente após o evento, sem complicações adicionais.

O medicamento Butilbrometo de escopolamina (Hyoscine butylbromide) foi relacionado a um episódio de alergia, caracterizado como hipersensibilidade, ou seja, uma resposta imunológica adversa ao uso do fármaco. O evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação total após a reação, sem necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Gadovist (Gadobutrol) esteve associado a uma reação alérgica, tecnicamente denominada hipersensibilidade, que representa uma resposta do sistema imunológico ao agente de contraste. O episódio não foi classificado como grave e o paciente se recuperou completamente após o evento, sem complicações.

O medicamento Dipifarma, cujo princípio ativo é o metamizol sódico, foi associado ao surgimento de prurido generalizado, caracterizando um quadro de hipersensibilidade (alergia), conforme descrito em reações alérgicas do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente do evento, sugerindo uma reação leve e autolimitada, compatível com quadros alérgicos leves segundo as diretrizes clínicas.

O medicamento Actemra, que contém tocilizumabe, foi relacionado ao aparecimento de hipertensão e sintomas oculares classificados como alergia do olho, dentro do contexto de manifestações oculares alérgicas. Não há informações sobre gravidade aumentada ou desfecho, mas a ausência de relato de gravidade e a natureza da reação sugerem um quadro não grave, devendo ser monitorado clinicamente conforme orientação médica.

O medicamento Montelukast, com princípio ativo montelucaste, foi associado a uma crise asmática, caracterizada como reação de hipersensibilidade do sistema imunológico. Não há evidência de gravidade aumentada, mas o evento ainda está em andamento e não foi resolvido, o que indica a necessidade de acompanhamento médico para ajuste do tratamento e controle dos sintomas, conforme recomendações para quadros de asma não controlada.

O medicamento Trimbrow, composto por dipropionato de beclometasona, fumarato de formoterol e brometo de glicopirrônio, foi relacionado ao desenvolvimento de uma crise asmática, enquadrada como reação de hipersensibilidade do sistema imunológico. O evento permanece em andamento e não foi resolvido, sem sinais de gravidade aumentada, sendo importante manter acompanhamento médico para reavaliação do controle da asma e ajuste terapêutico, conforme orientações clínicas para crises não controladas.

O medicamento Fostair, que contém dipropionato de beclometasona e fumarato de formoterol, foi associado a uma crise asmática, caracterizada como reação de hipersensibilidade do sistema imunológico. O quadro permanece em andamento e não foi resolvido, sem indicação de gravidade elevada, sendo recomendada a avaliação médica para revisão do tratamento e controle adequado da asma, conforme diretrizes para casos de descontrole.

O medicamento Azithromycin (princípio ativo: Azithromycin) foi associado a uma crise asmática, caracterizada como uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico. Embora não haja indicação de gravidade elevada ou desfecho grave, o quadro permanece não resolvido ou em andamento, sugerindo a necessidade de acompanhamento médico para controle dos sintomas e investigação de possíveis gatilhos, conforme orientações clínicas para reações respiratórias alérgicas.

O medicamento Prednisolone (princípio ativo: Prednisolone) está relacionado a uma crise asmática, descrita como uma reação de hipersensibilidade, indicando uma resposta alérgica do sistema imunológico. Não há evidência de

gravidade crítica ou desfecho grave, mas o evento ainda não foi resolvido, sendo importante manter o acompanhamento clínico para ajuste do tratamento e identificação de fatores desencadeantes, conforme recomendações para quadros alérgicos respiratórios.

O medicamento Allegra (princípio ativo: Fexofenadine hydrochloride) foi associado a uma crise asmática, considerada uma manifestação de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade elevada ou desfecho grave, mas o quadro permanece não resolvido, sendo recomendada avaliação médica para controle dos sintomas e investigação de possíveis causas, conforme diretrizes para reações alérgicas respiratórias.

O medicamento Nucala (princípio ativo: Mepolizumab) está relacionado a uma crise asmática, caracterizada como uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade crítica ou desfecho grave, mas o evento segue não resolvido, sendo importante acompanhamento médico para ajuste do tratamento e identificação de fatores desencadeantes, conforme orientações para quadros alérgicos respiratórios.

O medicamento Nucala (princípio ativo: Mepolizumab) foi associado a uma crise asmática, descrita como uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico. Não há evidência de gravidade elevada ou desfecho grave, mas o quadro permanece não resolvido, recomendando-se acompanhamento clínico para controle dos sintomas e investigação de possíveis gatilhos, conforme diretrizes para reações alérgicas respiratórias.

O medicamento Optiray 350, cujo princípio ativo é o ioversol, foi associado a um quadro de alergia a contraste, caracterizado como uma reação do sistema imunológico a substâncias químicas utilizadas em exames de imagem. A gravidade do evento é considerada alta, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação e foi classificada como clinicamente significativa, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico imediato e monitoramento rigoroso durante e após o uso de contrastes iodados. O desfecho relatado foi de recuperação completa do paciente após a reação.

O medicamento Dorflex, composto por cafeína, metamizol sódico e citrato de orfenadrina, foi relacionado a um episódio de engasgamento, interpretado como uma possível hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação adversa do sistema imunológico ao medicamento. Não há evidências de gravidade aumentada ou necessidade de hospitalização, e o desfecho do caso permanece desconhecido, indicando que a reação foi leve e não houve complicações clínicas relatadas.

O ácido fólico, utilizado como suplemento vitamínico, foi associado a um quadro de indisposição interpretado como hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente significativo, sugerindo que a reação teve impacto relevante para o paciente, mas não houve necessidade de hospitalização. O paciente se recuperou totalmente após o episódio.

O medicamento Riximyo, cujo princípio ativo é o rituximabe, foi relacionado a um episódio de indisposição classificado como hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente significativo, indicando que a reação teve impacto relevante para o paciente, mas não houve necessidade de hospitalização. O paciente se recuperou completamente após a reação.

O medicamento Henetix, com princípio ativo iobitridol, foi associado a um quadro de alergia classificado como hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade aumentada ou necessidade de hospitalização, e o paciente se recuperou totalmente após o episódio, indicando que a reação foi leve e autolimitada.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como reação alérgica não especificada, envolvendo o sistema imunológico. Não há indicação

de gravidade aumentada neste caso, e o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo uma reação leve e autolimitada.

A vancomicina, com princípio ativo vancomycin, desencadeou uma reação de hipersensibilidade (alergia), caracterizada como um quadro alérgico inespecífico relacionado ao sistema imunológico. Não há evidências de gravidade aumentada, e o paciente evoluiu para recuperação completa, indicando uma reação leve e resolutive.

O medicamento Marcain, cujo princípio ativo é o cloridrato de bupivacaína, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), descrito como um quadro alérgico inespecífico do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade relevante, e o paciente se recuperou totalmente, caracterizando uma reação leve e autolimitada.

O Kefazol, com princípio ativo cefazolina sódica, esteve associado a uma reação de hipersensibilidade (alergia), enquadrada como quadro alérgico inespecífico do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade aumentada, e o paciente apresentou recuperação completa, sugerindo uma reação leve e resolutive.

A vacina COVID-19 Janssen, cujo princípio ativo é a vacina COVID-19 NRVV Ad26 (JNJ 78436735), foi associada a um episódio de hipersensibilidade (alergia), classificado como clinicamente significativo e relacionado ao sistema imunológico. Neste caso, a reação foi considerada grave devido à classificação de efeito clinicamente relevante e o paciente ainda não se recuperou, indicando a necessidade de acompanhamento médico contínuo para monitoramento e manejo adequado.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), caracterizado por uma reação do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo que a reação foi leve e autolimitada, sem necessidade de intervenções adicionais.

O Cloridrato de vancomicina (vancomycin hydrochloride) provocou uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade importante, já que o paciente se recuperou completamente, indicando que a reação foi leve e controlada sem complicações.

O medicamento Tygacil, cujo princípio ativo é a tigeciclina, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade), manifestando-se como resposta do sistema imunológico. O caso não foi considerado grave, pois houve recuperação total do paciente, sugerindo que a reação foi leve e não exigiu medidas emergenciais.

O Iopromide, utilizado como contraste, causou uma alergia a contraste, caracterizada por uma resposta imunológica significativa. O evento foi considerado clinicamente relevante, pois foi classificado como outro efeito clinicamente significativo, mas o paciente se recuperou totalmente após a reação, indicando que, apesar da gravidade potencial, houve resolução completa do quadro.

O medicamento Ultravist, que também tem como princípio ativo o iopromide, foi responsável por uma alergia a contraste, ou seja, uma reação imunológica importante ao agente utilizado. O caso foi considerado clinicamente significativo, mas o paciente apresentou recuperação total, mostrando que, apesar da gravidade do evento, não houve consequências permanentes.

O medicamento Olanzapina mamey, cujo princípio ativo é Olanzapine, foi associado a um quadro de paralisia cerebral descrito como hipersensibilidade, classificado dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há informações suficientes sobre a gravidade clínica do evento, nem detalhes sobre a evolução ou conduta adotada, e o desfecho permanece desconhecido. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, mas não há evidências claras de gravidade ou desfecho grave neste registro.

O medicamento Vimpat, com princípio ativo Lacosamide, foi relacionado a um caso de paralisia cerebral descrito como hipersensibilidade, enquadrado entre os distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhes sobre a gravidade

do evento, conduta tomada ou evolução clínica, e o desfecho é desconhecido. A suspeita de relação causal foi registrada, mas não há evidências objetivas de gravidade relevante neste caso.

O medicamento Omeprazol, cujo princípio ativo é Omeprazole, foi associado a um episódio de parada respiratória descrito como alergia a poeira, dentro do contexto de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre a gravidade do evento, conduta adotada ou evolução clínica, e o desfecho permanece desconhecido. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, mas não há evidências clínicas suficientes para afirmar gravidade neste registro.

O medicamento Berotec, com princípio ativo Fenoterol hydrobromide, foi relacionado a um caso de parada respiratória descrito como alergia a poeira, classificado entre quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre a gravidade do evento, conduta tomada ou evolução clínica, e o desfecho é desconhecido. A suspeita de relação causal foi registrada, mas não há evidências objetivas de gravidade relevante neste caso.

O medicamento Atrovent, cujo princípio ativo é Ipratropium bromide, foi associado a um episódio de parada respiratória descrito como alergia a poeira, enquadrado em quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhes sobre a gravidade do evento, conduta adotada ou evolução clínica, e o desfecho permanece desconhecido. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, mas não há evidências clínicas suficientes para afirmar gravidade neste registro.

O medicamento Omeprazol (princípio ativo: Omeprazole) está relacionado a um caso de parada respiratória em um paciente com histórico de alergia a fungos, sendo classificado como um quadro clínico alérgico dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Apesar da gravidade potencial da reação descrita, não há informação suficiente sobre a evolução do caso ou a conduta adotada, e o desfecho permanece desconhecido. A ausência de confirmação de gravidade e desfecho impede recomendações específicas, mas a suspeita de relação entre o medicamento e o evento adverso justifica atenção clínica e acompanhamento especializado.

O Berotec (princípio ativo: Fenoterol hydrobromide) foi associado a um episódio de parada respiratória em paciente com alergia a fungos, sendo enquadrado como um quadro alérgico relacionado ao sistema imune. Não há detalhes sobre a gravidade clínica confirmada, conduta adotada ou evolução do caso, e o desfecho é desconhecido. Diante da suspeita de relação entre o uso do medicamento e o evento, recomenda-se vigilância clínica e avaliação médica criteriosa.

O medicamento Atrovent (princípio ativo: Ipratropium bromide) foi relacionado a uma parada respiratória em paciente com alergia a fungos, caracterizando um quadro alérgico do sistema imunitário. Não há informações sobre a gravidade confirmada, conduta tomada ou desfecho do caso, que permanece desconhecido. A suspeita de associação entre o uso do medicamento e o evento adverso reforça a necessidade de acompanhamento médico e investigação especializada.

O Omeprazol (princípio ativo: Omeprazole) foi associado a um caso de parada respiratória em paciente com alergia a animais, sendo considerado um quadro clínico alérgico dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há dados sobre a gravidade clínica, conduta adotada ou evolução do caso, e o desfecho é desconhecido. A suspeita de relação entre o medicamento e o evento adverso exige atenção clínica e acompanhamento por especialista.

O Berotec (princípio ativo: Fenoterol hydrobromide) está relacionado a um episódio de parada respiratória em paciente com alergia a animais, classificado como quadro alérgico do sistema imune. Não há informações sobre gravidade confirmada, conduta adotada ou desfecho, que permanece desconhecido. A suspeita de associação entre o medicamento e o evento adverso justifica avaliação médica detalhada e acompanhamento especializado.

O medicamento Atrovent, cujo princípio ativo é o brometo de ipratrópio, foi associado a um episódio de parada respiratória em um contexto de alergia a animais, sendo classificado como um quadro clínico alérgico relacionado a

distúrbios do sistema imunitário. Apesar da gravidade potencial da reação descrita, não há confirmação de gravidade clínica nem detalhes sobre o desfecho, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A ausência de informações sobre a evolução do caso impede recomendações específicas de conduta, mas episódios de parada respiratória exigem sempre avaliação médica imediata.

O medicamento Omeprazol, cujo princípio ativo é o omeprazol, foi relacionado a um caso de parada respiratória em um contexto de hipersensibilidade, caracterizando um quadro alérgico do sistema imunitário. Não há confirmação de gravidade clínica nem detalhes sobre o desfecho, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Diante de uma reação tão grave como parada respiratória, mesmo sem confirmação adicional, é fundamental buscar atendimento médico urgente.

O medicamento Berotec, com princípio ativo fenoterol hidrobrometo, foi associado a um episódio de parada respiratória em um contexto de hipersensibilidade, sendo classificado como um quadro alérgico do sistema imunitário. Não há confirmação de gravidade clínica nem informações sobre o desfecho, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Situações de parada respiratória são potencialmente graves e requerem avaliação médica imediata, mesmo que a gravidade não esteja explicitamente confirmada.

O medicamento Atrovent, cujo princípio ativo é o brometo de ipratrópio, foi relacionado a um episódio de parada respiratória em um contexto de hipersensibilidade, caracterizando um quadro alérgico do sistema imunitário. Não há confirmação de gravidade clínica nem detalhes sobre o desfecho, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Episódios de parada respiratória, mesmo sem confirmação de gravidade, sempre demandam avaliação médica urgente.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade) classificado como distúrbio do sistema imunitário. O caso foi considerado suspeito em relação ao medicamento, mas o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente. Em situações de alergia medicamentosa, é importante relatar o evento ao médico e evitar novas exposições ao agente suspeito.

O medicamento Potasio quelatado, cujo princípio ativo é o Potassium, foi utilizado sem prescrição médica, o que caracteriza uma reação de hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). Não há sintomas específicos ou gravidade clínica detalhada no registro, mas o uso de medicamentos sem orientação pode causar reações adversas imunológicas e deve ser evitado. O caso permanece em andamento, sem resolução até o momento.

O medicamento Finshape, que contém o princípio ativo Orlistat, foi utilizado sem prescrição médica, resultando em uma reação de hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). Não há detalhes sobre sintomas ou gravidade, mas o uso sem orientação pode desencadear reações alérgicas e outros efeitos adversos, sendo importante buscar avaliação médica. O desfecho ainda está em andamento, sem recuperação relatada.

O medicamento Rosucor, cujo princípio ativo é Rosuvastatin calcium, foi utilizado sem prescrição médica, levando a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). Não foram informados sintomas específicos ou gravidade, mas o uso inadequado pode causar reações imunológicas e outros riscos à saúde. O caso segue sem resolução, estando em andamento.

O medicamento Lipidil, com princípio ativo Fenofibrate, foi utilizado sem prescrição médica, ocasionando uma reação de hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). Não há descrição de sintomas ou gravidade, mas o uso sem orientação pode resultar em reações adversas e deve ser evitado. O desfecho permanece não resolvido e em andamento.

O medicamento Clonazepam, cujo princípio ativo também é Clonazepam, foi utilizado sem prescrição médica, caracterizando uma reação de hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). Não há detalhes sobre sintomas ou gravidade, mas o uso sem acompanhamento pode causar reações adversas e riscos à saúde. O



caso segue em andamento, sem recuperação até o momento.

O medicamento Trazodona (princípio ativo: Trazodone) foi utilizado sem prescrição médica, o que pode resultar em hipersensibilidade medicamentosa, uma reação do sistema imunológico que pode se manifestar como alergia a medicamentos. Não há informações específicas sobre sintomas ou gravidade clínica neste caso, mas o uso sem orientação médica aumenta o risco de reações adversas e dificulta o controle adequado da situação. O desfecho relatado indica que o quadro permanece em andamento, sendo fundamental interromper o uso e buscar avaliação médica para diagnóstico e conduta apropriada.

O medicamento Florent, cujo princípio ativo é *Saccharomyces boulardii*, foi utilizado sem prescrição médica, levando a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma possível reação alérgica ao medicamento. Não há detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade, mas o uso sem orientação pode aumentar o risco de reações adversas e dificultar o manejo. O caso permanece não resolvido, sendo importante suspender o uso e procurar avaliação médica para investigação e tratamento adequados.

O Ciprofibrato (princípio ativo: Ciprofibrate) foi administrado sem prescrição médica, resultando em suspeita de hipersensibilidade medicamentosa, que corresponde a uma reação alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Não há descrição de sintomas ou gravidade, mas o uso sem acompanhamento médico pode agravar o risco de eventos adversos. O quadro segue em andamento, sendo recomendado interromper o uso e buscar orientação médica para avaliação e conduta.

O medicamento Ciprofloxacino (princípio ativo: Ciprofloxacin hydrochloride) foi utilizado sem prescrição médica, o que levou a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa, caracterizando uma possível reação alérgica ao medicamento. Não há detalhes sobre sintomas ou gravidade, mas o uso sem orientação médica pode aumentar o risco de complicações. O desfecho indica que a situação ainda não foi resolvida, sendo fundamental suspender o uso e procurar avaliação médica para diagnóstico e tratamento adequados.

O medicamento Amato, cujo princípio ativo é Topiramate, foi utilizado sem prescrição médica, resultando em suspeita de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma possível reação alérgica ao medicamento. Não há informações sobre sintomas específicos ou gravidade, mas o uso sem orientação médica pode aumentar o risco de reações adversas e dificultar o manejo clínico. O caso permanece em andamento, sendo importante interromper o uso e buscar avaliação médica para investigação e conduta apropriadas.

O medicamento Cilostazol, cujo princípio ativo é o próprio Cilostazol, foi utilizado sem prescrição médica, o que caracteriza um uso inadequado e pode aumentar o risco de hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). A reação relatada está relacionada a distúrbios do sistema imunitário, sugerindo uma resposta alérgica, mas não há detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade. O caso permanece em andamento, sem resolução até o momento, e é importante ressaltar que o uso de qualquer medicamento deve ser sempre orientado por um profissional de saúde para evitar reações adversas e garantir segurança.

O Levotac, que tem como princípio ativo a Levofloxacina, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação do sistema imunológico. A gravidade não foi classificada como grave e o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente. Em situações de alergia medicamentosa, é fundamental suspender o uso do medicamento suspeito e buscar orientação médica para evitar recorrências e garantir o manejo adequado.

O medicamento Sinvascor, cujo princípio ativo é a Sinvastatina, foi relacionado ao aparecimento de manchas na pele, indicando uma possível reação alérgica (hipersensibilidade) de relevância clínica. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, embora o desfecho seja desconhecido. Diante de manifestações cutâneas após o uso de medicamentos, recomenda-se avaliação médica imediata para investigação, suspensão do agente suspeito e definição da conduta mais segura.

O AAS (ácido acetilsalicílico) foi associado ao surgimento de manchas cutâneas, sugerindo uma reação alérgica (hipersensibilidade) de importância clínica. O evento foi classificado como clinicamente significativo e grave, mas não há informação sobre a evolução do caso. Em situações como essa, é essencial interromper o uso do medicamento e procurar avaliação médica para diagnóstico e orientação sobre alternativas terapêuticas seguras.

A Clortalidona, cujo princípio ativo é a Clortalidona, foi relacionada ao aparecimento de manchas na pele, caracterizando uma reação alérgica (hipersensibilidade) considerada clinicamente significativa e grave. O desfecho do caso não foi informado. Diante de reações cutâneas após o uso de medicamentos, é fundamental buscar avaliação médica para investigação, suspensão do medicamento suspeito e definição do tratamento adequado.

O medicamento Vitamina D, cujo princípio ativo é o ergocalciferol, foi associado ao surgimento de manchas na pele, caracterizando um quadro de hipersensibilidade (alergia) que se manifesta por reações cutâneas. Essa reação é considerada clinicamente significativa e potencialmente grave, pois envolve o sistema imunológico e pode indicar uma resposta alérgica relevante. Não há informações sobre a evolução do caso ou conduta adotada, sendo importante que o paciente procure avaliação médica para confirmação do diagnóstico e orientação adequada.

O medicamento Lisinopril, com princípio ativo lisinopril dihydrate, foi relacionado ao aparecimento de manchas cutâneas, sugerindo uma reação de hipersensibilidade (alergia) que afeta a pele. Trata-se de um evento clinicamente significativo e considerado grave, pois envolve o sistema imunológico e pode indicar uma resposta alérgica importante. Não há detalhes sobre a evolução do quadro ou medidas tomadas, sendo fundamental buscar avaliação médica para investigação e manejo apropriado.

O medicamento Vitamin D, cujo princípio ativo é o ergocalciferol, foi associado ao desenvolvimento de manchas na pele, caracterizando uma reação de hipersensibilidade (alergia) com manifestação cutânea. A gravidade é considerada clinicamente significativa e grave, pois envolve o sistema imunológico e pode indicar uma resposta alérgica relevante. Não há informações sobre a evolução do caso ou conduta adotada, sendo recomendada avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição do tratamento.

O medicamento Atenolol, com princípio ativo atenolol, foi relacionado ao surgimento de manchas cutâneas, indicando uma reação de hipersensibilidade (alergia) que se manifesta na pele. Esse evento é considerado clinicamente significativo e grave, pois envolve o sistema imunológico e pode representar uma resposta alérgica importante. Não há informações sobre a evolução do quadro ou conduta adotada, sendo essencial procurar avaliação médica para investigação e orientação adequada.

O medicamento Cosentyx, cujo princípio ativo é secukinumabe, foi associado ao aparecimento de manchas cutâneas, caracterizando uma reação de hipersensibilidade (alergia) com manifestação na pele. Trata-se de um evento clinicamente significativo e considerado grave, pois envolve o sistema imunológico e pode indicar uma resposta alérgica relevante. Não há informações sobre a evolução do caso ou medidas tomadas, sendo importante buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição do manejo.

O medicamento Tylenol, cujo princípio ativo é o paracetamol, foi associado a um quadro de vasculite, que é uma reação de hipersensibilidade medicamentosa caracterizada por inflamação dos vasos sanguíneos. Neste caso, a reação foi considerada não grave, pois o paciente se recuperou completamente após o evento, sem complicações relatadas. A conduta recomendada é evitar nova exposição ao medicamento e informar o profissional de saúde sobre o episódio para futuras prescrições.

O medicamento Tamarine, composto pelos princípios ativos Cassia fistula extract, Senna alexandrina powder e Tamarindus indica extract, esteve relacionado a um episódio de vasculite, uma reação de hipersensibilidade medicamentosa que envolve inflamação dos vasos sanguíneos. O evento não foi considerado grave, já que houve recuperação total do paciente. Recomenda-se evitar o uso futuro do produto e comunicar o ocorrido ao médico responsável.

O medicamento Vancotrat, cujo princípio ativo é a vancomicina, foi associado a um caso de vasculite, que é uma reação de hipersensibilidade medicamentosa manifestada por inflamação dos vasos sanguíneos. O episódio não foi grave, pois o paciente se recuperou completamente. É importante evitar o uso futuro da vancomicina e informar o profissional de saúde sobre essa reação para prevenir recorrências.

O medicamento Torgena, que contém os princípios ativos avibactam e ceftazidima, esteve envolvido em um caso de vasculite, uma reação de hipersensibilidade medicamentosa caracterizada por inflamação dos vasos sanguíneos. O evento não foi considerado grave, já que o paciente se recuperou totalmente. Recomenda-se evitar nova exposição ao medicamento e relatar o episódio ao médico para futuras decisões terapêuticas.

O medicamento Meronem, cujo princípio ativo é o meropenem, foi relacionado a um episódio de vasculite, uma reação de hipersensibilidade medicamentosa que se manifesta por inflamação dos vasos sanguíneos. O caso não foi grave, pois houve recuperação completa do paciente. A orientação é evitar o uso futuro do meropenem e informar o profissional de saúde sobre a reação para prevenir novos episódios.

O medicamento Teicoplanina, cujo princípio ativo é a teicoplanina, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade aumentada ou complicações clínicas relevantes neste caso, e não foram fornecidos detalhes sobre o desfecho ou a conduta adotada. A reação sugere um quadro leve de alergia medicamentosa, sendo importante considerar avaliação clínica estruturada e acompanhamento para evitar novas exposições.

A Polimixina B, com princípio ativo polymyxin b, foi relacionada a um episódio de alergia do tipo hipersensibilidade, classificado como distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente evoluiu para recuperação completa, indicando um quadro leve de reação alérgica. A conduta recomendada é evitar novas exposições ao medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação futura.

O medicamento Damater, composto por múltiplos princípios ativos como ácido ascórbico, betacaroteno, colecalciferol, cianocobalamina, entre outros, foi associado a um quadro de bronquiolite relacionado à alergia ao leite, enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade aumentada ou desfecho, e a relação com alergia alimentar sugere a necessidade de investigação clínica detalhada para confirmação do diagnóstico e orientação sobre restrição alimentar e acompanhamento especializado.

O Paclitaxel, cujo princípio ativo é o próprio paclitaxel, foi relacionado a um episódio de alergia do tipo hipersensibilidade, classificado como distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente apresentou resolução completa do quadro, sugerindo uma reação alérgica leve. Recomenda-se evitar novas exposições ao medicamento e realizar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição de conduta futura.

O Omnipaque, com princípio ativo iohexol, foi associado a um episódio de alergia a iodo, classificado como distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando uma reação alérgica leve. A conduta recomendada é evitar novas exposições a contrastes iodados e buscar avaliação com especialista para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras em exames futuros.

O medicamento Colistimetato de sódio (princípio ativo: Colistimethate sodium) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, caracterizado como uma reação alérgica do tipo imunológica. Não há indicação de gravidade aumentada neste caso, e o paciente evoluiu para recuperação completa, sugerindo que a reação foi leve e adequadamente manejada, conforme esperado para quadros alérgicos não complicados.

O medicamento Optiray 320, cujo princípio ativo é o Ioversol, provocou uma reação de alergia a contraste, que é uma resposta imunológica a substâncias químicas utilizadas em exames de imagem. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, conforme indicado, mas o paciente se recuperou totalmente após a conduta

adequada, o que reforça a importância do reconhecimento e manejo imediato dessas reações em ambiente controlado.

O medicamento Tramal (princípio ativo: Tramadol hydrochloride) desencadeou um episódio de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica. Não há detalhes sobre gravidade aumentada, e o paciente apresentou resolução completa do quadro, indicando que a reação foi leve e controlada sem complicações.

A Pregabalina (princípio ativo: Pregabalin) foi relacionada ao surgimento de náusea, classificada como manifestação de hipersensibilidade e considerada clinicamente significativa e grave. O paciente encontra-se em processo de recuperação, o que destaca a necessidade de acompanhamento até resolução completa, especialmente em reações consideradas graves.

O medicamento Cloridrato de duloxetina (princípio ativo: Duloxetine hydrochloride) causou náusea, interpretada como uma reação de hipersensibilidade de relevância clínica e gravidade significativa. O paciente está em recuperação, o que indica que a conduta foi adequada, mas o caso requer monitoramento até a resolução total dos sintomas.

O medicamento Tenofovir + lamivudine, que contém os princípios ativos lamivudina e tenofovir disoproxil fumarato, foi associado a um quadro de náusea relacionado à hipersensibilidade (alergia), classificado como clinicamente significativo. A gravidade do evento é sustentada pela indicação de outro efeito clinicamente relevante, e o paciente encontra-se em recuperação. A conduta recomendada é manter acompanhamento médico para monitorar a evolução e evitar reexposição ao medicamento, reforçando a importância de relatar qualquer sintoma novo ou agravamento ao profissional de saúde.

O medicamento Meropenem, cujo princípio ativo é meropenem sodium carbonate, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação. O paciente já se encontra recuperado, e a conduta adequada inclui evitar o uso futuro deste antibiótico e garantir acompanhamento com especialista para avaliação de alternativas seguras, além de registrar a alergia em prontuário para prevenir novas exposições.

O medicamento Gadovist, com princípio ativo gadobutrol, foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), mas não houve indicação de gravidade relevante, e o paciente já está recuperado. Nestes casos, recomenda-se informar o profissional de saúde sobre o evento em futuras exposições a contrastes e considerar avaliação com alergista para orientação individualizada.

O medicamento Sucrofer, cujo princípio ativo é saccharated iron oxide, foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), mas não há informações suficientes sobre a gravidade, evolução ou desfecho do caso. Diante de qualquer suspeita de reação alérgica, é importante suspender o uso do medicamento e buscar avaliação médica para investigação e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Dienogest, com princípio ativo dienogest, foi associado a um episódio de alergia a contraste, considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação. O paciente já está recuperado, e a conduta recomendada é evitar reexposição a contrastes relacionados e garantir acompanhamento com especialista para avaliação de risco em procedimentos futuros, além de registrar a alergia em prontuário.

O medicamento Sertraline, cujo princípio ativo também é Sertraline, foi associado a um episódio de alergia a contraste, uma reação do sistema imunológico que pode ocorrer após exposição a substâncias químicas usadas em exames de imagem. Neste caso, a gravidade da reação é evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando um quadro clínico importante que exigiu cuidados médicos intensivos. O paciente se recuperou totalmente após o evento, e a relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita.

O medicamento Forxiga, que contém o princípio ativo Dapagliflozin propanediol monohydrate, esteve relacionado a um caso de alergia a contraste, caracterizada por uma resposta do sistema imunológico a substâncias químicas utilizadas em procedimentos diagnósticos. A gravidade do evento é confirmada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que demonstra que a reação foi clinicamente relevante e exigiu intervenção médica. O paciente evoluiu para recuperação completa, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita.

O medicamento Metformin, cujo princípio ativo é Metformin, foi associado a uma reação de alergia a contraste, que consiste em uma resposta imunológica adversa a substâncias químicas usadas em exames de imagem. A gravidade do caso é comprovada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando que o quadro foi significativo e demandou acompanhamento médico. O paciente se recuperou totalmente após o evento, e a relação com o uso do medicamento foi considerada suspeita.

O medicamento Insuline nph, com princípio ativo Insulin isophane porcine, esteve envolvido em um episódio de alergia a contraste, uma reação do sistema imunológico a substâncias químicas administradas em exames diagnósticos. A gravidade do evento é demonstrada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que indica que a reação foi relevante do ponto de vista clínico e exigiu cuidados médicos. O paciente apresentou recuperação completa após o episódio, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é Gadobutrol, foi relacionado a um caso de alergia a contraste, que é uma resposta imunológica adversa a substâncias químicas utilizadas em exames de imagem. A gravidade do evento é evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, mostrando que a reação foi clinicamente importante e necessitou de intervenção médica. O paciente se recuperou totalmente após o episódio, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o Iopromide, foi associado a um quadro de alergia a contraste, caracterizado como uma reação imunológica relevante. A gravidade do evento foi considerada clinicamente significativa, o que indica a necessidade de atenção médica imediata, conforme evidenciado pela classificação de gravidade informada. O paciente evoluiu para recuperação completa após a reação, sugerindo que as medidas adotadas foram eficazes para resolução do quadro.

A Cefalotina, que tem como princípio ativo a Cefalotin, desencadeou uma reação de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como um quadro alérgico relevante do sistema imunológico. O evento foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando a necessidade de intervenção médica intensiva. O paciente se recuperou totalmente após o episódio, indicando resolução do quadro após as medidas adotadas.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é o Gadobutrol, foi relacionado a uma alergia a contraste, uma reação imunológica significativa. O evento foi classificado como clinicamente relevante, exigindo atenção médica imediata devido ao potencial risco associado a esse tipo de reação. O paciente apresentou recuperação completa após o episódio, demonstrando que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro.

O Ultravist, com princípio ativo Iopromide, esteve envolvido em um caso de alergia a contraste, caracterizada como uma reação imunológica importante. O evento foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, o que reforça a necessidade de monitoramento e intervenção médica adequada. O desfecho do caso não foi informado, impossibilitando afirmar a evolução clínica do paciente.

O medicamento Rinvoq, cujo princípio ativo é Upadacitinib, foi associado a um episódio de ideação suicida, registrado sob o termo hipersensibilidade, embora não haja indicação de gravidade relevante neste caso. O paciente se recuperou completamente após o evento, sugerindo que a situação foi resolvida sem complicações adicionais.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, foi associado a um quadro de alergia a contraste, caracterizado como uma reação do sistema imunológico a substâncias químicas utilizadas em exames de imagem. A gravidade foi considerada clinicamente significativa, pois o registro indica um efeito importante para a saúde, mas o paciente evoluiu para recuperação completa após a conduta adequada. Reações alérgicas a contrastes iodados exigem atenção imediata e acompanhamento médico para evitar complicações.

O Henetix, que contém o princípio ativo iobitridol, esteve relacionado a um episódio de alergia a iodo, uma reação imunológica a substâncias iodadas frequentemente usadas em exames de imagem. Neste caso, a reação não foi considerada grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro sem maiores complicações.

O medicamento Xarelto, cujo princípio ativo é o rivaroxabana, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade (reação alérgica), identificado durante o contexto de cirurgia. Não há indicação de gravidade elevada e o paciente encontra-se em processo de recuperação, sugerindo que a reação foi controlada e está evoluindo de forma favorável.

O Zolpidem, com princípio ativo de mesmo nome, foi associado a um episódio de hipersensibilidade (reação alérgica) durante o contexto de cirurgia. Não há evidência de gravidade importante e o paciente está em recuperação, indicando que a reação foi manejada adequadamente e está em resolução.

O Vectibix, cujo princípio ativo é o panitumumabe, esteve relacionado a um quadro de hipersensibilidade (reação alérgica) no contexto de cirurgia. Não foi relatada gravidade significativa e o paciente está em processo de recuperação, mostrando que a conduta adotada foi eficaz para o controle da reação.

O medicamento Predsim, que contém o princípio ativo prednisolone sodium phosphate, foi associado a um quadro de dependência de medicamento, classificado como uma reação de hipersensibilidade (alergia) dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Segundo as diretrizes clínicas, o uso de corticoides como a prednisolona deve ser supervisionado por médico, especialmente em crises, para evitar riscos de efeitos adversos e dependência, não sendo recomendado o uso repetido sem orientação.

O Decongex plus, composto por brompheniramine maleate e phenylephrine hydrochloride, apresentou relato de dependência de medicamento, caracterizada como reação de hipersensibilidade (alergia) relacionada ao sistema imunitário. Não há sinais de gravidade importante ou desfecho informado, e a suspeita recai sobre o uso do medicamento. É importante evitar o uso contínuo ou indiscriminado de descongestionantes e antialérgicos sem acompanhamento médico, pois isso pode levar a efeitos adversos e dependência, sendo necessária avaliação clínica para conduta adequada.

O Nasonex, cujo princípio ativo é mometasone furoate, foi relacionado a um caso de dependência de medicamento, enquadrado como reação de hipersensibilidade (alergia) no contexto de distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa ou desfecho relatado, e a relação com o medicamento é suspeita. O uso de corticoides nasais deve ser mantido conforme prescrição médica para controle de sintomas alérgicos, evitando uso excessivo ou sem acompanhamento para prevenir efeitos adversos e dependência.

O medicamento Zyxem, que contém levocetirizine dihydrochloride, foi associado a dependência de medicamento, considerada uma reação de hipersensibilidade (alergia) dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade relevante ou desfecho conhecido, sendo a relação com o medicamento suspeita. O uso prolongado de anti-histamínicos deve ser avaliado por um especialista para evitar riscos de dependência e garantir o tratamento correto da condição alérgica.

O Dotarem, cujo princípio ativo é meglumine gadoterate, foi relacionado a um episódio de alergia, classificado como reação de hipersensibilidade (alergia) no âmbito dos distúrbios do sistema imunitário. Não há informações

sobre gravidade, desfecho ou ação adotada, mas a suspeita recai sobre o medicamento. Em casos de suspeita de alergia a contraste, é fundamental informar a equipe médica antes de novos exames para avaliação do risco e definição de conduta segura.

O medicamento Corticosteroid nos, cujo princípio ativo não foi detalhado, foi associado a um quadro de dermatite atópica de rebote, caracterizado por uma reação de hipersensibilidade do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave, pois o paciente encontra-se em recuperação e não houve indicação de complicações importantes. A conduta clínica, baseada na evolução favorável, sugere acompanhamento e manejo dos sintomas, sem necessidade de intervenções emergenciais.

O produto Cetaphil, contendo cetyl alcohol e sodium lauryl sulfate como princípios ativos, esteve relacionado ao desenvolvimento de dermatite atópica de rebote, uma manifestação de hipersensibilidade do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade significativa, já que o paciente está em recuperação e não foram relatadas complicações sérias. O caso indica que a reação foi controlada com medidas de suporte e acompanhamento clínico.

O medicamento Fexofenadine hydrochloride, com o mesmo princípio ativo, foi associado a dermatite atópica de rebote, indicando uma resposta de hipersensibilidade do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave, pois o paciente está em processo de recuperação e não houve relato de agravamento. A evolução sugere que a reação foi autolimitada e manejada de forma conservadora.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, foi relacionado a um episódio de alergia inespecífica (SOE), caracterizando uma reação de hipersensibilidade do sistema imunológico. O caso não foi considerado grave, pois o paciente já se encontra recuperado e não houve complicações adicionais. A conduta adotada foi suficiente para resolução completa do quadro.

O medicamento Nicotine, com princípio ativo nicotine polacrilex, esteve associado a uma reação alérgica, evidenciando hipersensibilidade do sistema imunológico. O evento não foi classificado como grave, já que o paciente se recuperou totalmente e não houve relato de consequências importantes. O desfecho indica resolução espontânea ou com medidas clínicas simples.

O medicamento Trimebutine maleate, cujo princípio ativo é o próprio trimebutine maleate, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação alérgica do sistema imunológico. O caso foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, e até o momento o paciente não se recuperou totalmente, permanecendo com sintomas em andamento. Diante desse cenário, a conduta recomendada é a suspensão imediata do medicamento suspeito, monitoramento rigoroso e acompanhamento médico especializado para manejo da reação alérgica, conforme orientações da ASBAI para quadros graves.

O medicamento Ciprofloxacin hydrochloride, com princípio ativo ciprofloxacin hydrochloride, desencadeou uma reação de alergia (hipersensibilidade), caracterizada por resposta imunológica inadequada ao fármaco. A gravidade do evento é evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, e o paciente ainda não apresentou resolução completa dos sintomas, estando em acompanhamento. Nestes casos, é fundamental interromper o uso do medicamento, garantir suporte clínico imediato e buscar avaliação de um especialista em alergia para definição do tratamento e prevenção de novas exposições.

O medicamento Tetrabenazina, cujo princípio ativo é tetrabenazine, foi relacionado a um problema de prescrição envolvendo hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica ao medicamento. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, portanto não é possível afirmar se houve complicações ou necessidade de intervenção médica adicional. Recomenda-se que, diante de suspeita de alergia medicamentosa, o paciente seja avaliado por um profissional de saúde para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas terapêuticas seguras.

O medicamento Austedo, com princípio ativo deutetrabenazine, apresentou relato de problema de prescrição relacionado à hipersensibilidade medicamentosa, indicando possível reação alérgica ao uso do produto. Não há detalhes sobre a gravidade do evento ou evolução clínica, o que impede uma avaliação mais precisa do risco. Em situações de suspeita de alergia a medicamentos, é importante buscar orientação médica para investigação adequada e definição de conduta, evitando reexposição ao agente suspeito.

O medicamento Shingrix, que contém como princípio ativo a vacina recombinante contra varicela zoster (Varicella zoster vaccine rgE - CHO), foi associado a uma erupção cutânea no local da injeção, caracterizada como reação de hipersensibilidade. Não há indicação de gravidade aumentada ou necessidade de hospitalização, nem informações sobre o desfecho do caso. Em geral, reações locais leves após vacinação são autolimitadas, mas é importante monitorar a evolução e procurar avaliação médica caso haja piora ou sintomas sistêmicos.

O medicamento Soro glicosado isotônico, cujo princípio ativo é a glucose, foi administrado de forma incorreta ao paciente, resultando em hipersensibilidade no local de aplicação, ou seja, uma reação local caracterizada por desconforto ou irritação. Não há informação sobre gravidade relevante, e o paciente se recuperou totalmente após o evento, indicando resolução completa do quadro.

O Optiray, que contém o princípio ativo ioversol, provocou uma erupção cutânea associada a hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica leve do tipo cutânea. Não há evidências de gravidade significativa, e o paciente apresentou recuperação total após o episódio, sem complicações.

O medicamento Cetuximab, com o mesmo princípio ativo, causou uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma alergia, sem sinais de gravidade importante. O paciente se recuperou completamente após o evento, não havendo necessidade de intervenções adicionais.

O Kefazol, cujo princípio ativo é cefazolina sódica, desencadeou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, sem sinais de gravidade relevante. O paciente evoluiu para recuperação total, sem complicações adicionais.

O medicamento Carbamazepina, com o mesmo princípio ativo, provocou um choque anafilático, uma reação alérgica grave que exigiu hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando a gravidade do quadro. Apesar da severidade, o paciente se recuperou totalmente após o tratamento adequado.

O medicamento Tysabri (princípio ativo Natalizumab) foi associado a um episódio de choque anafilático, uma reação de hipersensibilidade grave caracterizada por resposta alérgica intensa e potencialmente fatal. A gravidade do caso é evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando risco significativo à saúde do paciente. Após a intervenção médica adequada, o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente.

O medicamento Tysabri (princípio ativo Natalizumab) esteve relacionado a um caso de choque anafilático, que é uma reação alérgica aguda e grave, exigindo hospitalização devido ao risco de complicações sérias. O paciente foi tratado e apresentou recuperação total após o evento, demonstrando a importância do manejo rápido e adequado em situações de hipersensibilidade medicamentosa.

O medicamento Sulfato de magnésio (princípio ativo Magnesium sulfate) foi associado a um quadro de alergia, descrito como hipersensibilidade, sem indicação de gravidade elevada ou necessidade de hospitalização. O paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo que a reação foi leve e manejada de forma eficaz.

O medicamento Omniscan (princípio ativo Gadodiamide) esteve envolvido em um episódio de alergia a contraste, caracterizada por reação alérgica após exposição ao agente de contraste, mas sem sinais de gravidade ou necessidade de hospitalização. O paciente se recuperou completamente, indicando que a reação foi leve e controlada adequadamente.



O medicamento Omniscan (princípio ativo Gadodiamide) foi relacionado a um caso de alergia, descrito como hipersensibilidade, sem evidências de gravidade significativa. O paciente encontra-se em processo de recuperação, sugerindo que a reação foi moderada ou leve e está evoluindo de forma favorável.

O medicamento Feminis, que contém uma combinação de vitaminas, minerais e óleo de peixe, foi associado ao surgimento de fezes mucosas em um paciente com histórico de alergia ao leite. Essa reação está relacionada a distúrbios do sistema imunológico, especificamente a alergias a alimentos, aditivos ou medicamentos, e pode indicar uma resposta alérgica leve, já que não há sinais de gravidade clínica ou complicações descritas. O quadro permanece em andamento, sem resolução até o momento, e recomenda-se acompanhamento clínico para monitorar a evolução dos sintomas e avaliar a necessidade de ajustes na medicação ou investigação de outros gatilhos alimentares.

O medicamento Dexfer, cujo princípio ativo é o complexo de hidróxido férrico polimalto, foi relacionado ao aparecimento de fezes mucosas em um paciente com alergia ao leite. Essa manifestação sugere uma possível reação alérgica leve, envolvendo o sistema imunológico e associada a alergias alimentares ou a medicamentos, sem evidências de gravidade ou complicações adicionais. O quadro permanece não resolvido, sendo importante manter o acompanhamento médico para avaliar a persistência dos sintomas e considerar alternativas terapêuticas caso necessário.

A domperidona, utilizada para distúrbios gastrointestinais, foi associada ao surgimento de fezes mucosas em um paciente com alergia ao leite. Essa reação pode indicar uma resposta alérgica leve, relacionada a distúrbios do sistema imunológico e a alergias alimentares ou medicamentosas, sem sinais de gravidade clínica ou evolução para quadros mais sérios. O evento permanece em andamento, sendo recomendada a observação clínica e reavaliação do tratamento caso os sintomas persistam.

O medicamento Leg, cujo princípio ativo é a desloratadina, foi associado ao aparecimento de fezes mucosas em um paciente com alergia ao leite. Essa reação sugere uma possível resposta alérgica leve, envolvendo o sistema imunológico e relacionada a alergias alimentares ou medicamentosas, sem indícios de gravidade ou complicações. O quadro segue sem resolução, sendo importante o acompanhamento médico para monitorar a evolução e considerar ajustes terapêuticos se necessário.

A vancomicina, antibiótico cujo princípio ativo é o cloridrato de vancomicina, foi relacionada a um quadro de alergia (hipersensibilidade) em um paciente, caracterizando uma reação do sistema imunológico. Embora não haja detalhes sobre a gravidade ou evolução do caso, a suspeita de hipersensibilidade requer atenção, pois reações alérgicas a antibióticos podem variar de leves a graves. O desfecho é desconhecido, sendo fundamental monitorar sinais de gravidade e buscar avaliação médica imediata caso haja piora dos sintomas.

O medicamento Hypoflox, cujo princípio ativo é ciprofloxacina lactate, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, manifestação que se enquadra nos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade clínica relevante neste caso, e o paciente apresentou recuperação completa após o evento, sugerindo uma reação leve e autolimitada.

O medicamento Acwy vax, que contém como princípio ativo o meningococcal vaccine A/C/Y/W polysacch, desencadeou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, classificada como clinicamente significativa devido à gravidade relatada. O evento está relacionado a distúrbios do sistema imunitário e, no momento do registro, o paciente encontrava-se em recuperação, indicando a necessidade de acompanhamento médico até resolução completa.

O medicamento Meningococcal vaccine B, com o mesmo princípio ativo, foi associado a uma reação de hipersensibilidade considerada clinicamente significativa, evidenciada pela gravidade do quadro. A manifestação está relacionada a distúrbios do sistema imunitário e, até o momento, o paciente permanece em recuperação, sendo importante o monitoramento contínuo da evolução clínica.

O medicamento Arnigel, cujo princípio ativo é arnica montana, foi relacionado a um quadro de inflamação do tecido celular ou conjuntivo, interpretado como uma reação de hipersensibilidade do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade relevante e o desfecho permanece desconhecido, não sendo possível afirmar a evolução clínica do paciente.

O medicamento Acheflan, com princípio ativo varronia curassavica, esteve associado a inflamação do tecido celular ou conjuntivo, caracterizando uma reação de hipersensibilidade do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade importante e o desfecho do caso é desconhecido, impossibilitando detalhar a evolução do paciente.

O medicamento Shingrix, que contém como princípio ativo a vacina recombinante contra o vírus varicela-zoster (Varicella zoster vaccine rgE produzido em células CHO), foi associado a um quadro de inflamação do tecido celular ou conjuntivo, interpretado como uma reação de hipersensibilidade (alergia). Embora não haja indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, trata-se de uma manifestação alérgica do sistema imune, que deve ser monitorada e avaliada clinicamente para evitar recorrências ou agravamento.

O Cloridrato de vancomicina (Vancomycin hydrochloride) foi relacionado a um episódio de alergia, caracterizado como hipersensibilidade, sem sinais de gravidade importante e com resolução completa do quadro. A reação foi do tipo alérgica, envolvendo o sistema imunológico, e o paciente se recuperou após a conduta adequada, não havendo necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Sucrofer, cujo princípio ativo é o óxido de ferro sacarato (Saccharated iron oxide), desencadeou uma reação alérgica classificada como hipersensibilidade, sem evidências de gravidade significativa. O quadro foi resolvido, indicando que a conduta adotada foi suficiente para controlar a manifestação alérgica, que envolveu o sistema imunológico.

O uso de Metformin (Metformin hydrochloride) foi associado a um caso de desordem respiratória neonatal, interpretada como uma possível alergia ao leite, envolvendo mecanismos imunológicos. Não há indicação de gravidade elevada, mas o quadro permanece em andamento, sem resolução até o momento, o que exige acompanhamento clínico para monitorar a evolução e evitar complicações.

O medicamento Ultravist, que tem como princípio ativo o iopromida (Iopromide), foi relacionado a uma reação alérgica ao contraste, considerada clinicamente significativa e classificada como grave. O paciente apresentou um quadro de alergia envolvendo o sistema imunológico, mas evoluiu para recuperação completa após a conduta adequada, ressaltando a importância de monitoramento rigoroso em casos de alergia a contraste.

O medicamento Sucrofer, cujo princípio ativo é o óxido de ferro sacarato, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado por uma reação do sistema imunológico a uma substância química. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente, sugerindo um evento leve e autolimitado. A conduta recomendada em casos semelhantes é interromper o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O Gadovist, que contém o princípio ativo gadobutrol, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação imunológica adversa após exposição ao contraste. O evento não foi considerado grave, já que o paciente se recuperou completamente, indicando um quadro leve. Em situações como essa, recomenda-se evitar novas exposições ao agente suspeito e consultar um especialista para avaliação e orientação sobre exames futuros com contraste.

O medicamento Gadovist, à base de gadobutrol, esteve envolvido em uma reação alérgica (hipersensibilidade), evidenciando resposta do sistema imunológico ao contraste utilizado em exames. O caso não apresentou gravidade significativa, pois houve recuperação total do paciente, sugerindo um evento leve. A recomendação é evitar o uso futuro do mesmo contraste e buscar orientação médica para alternativas seguras em exames de

imagem.

O medicamento Xolair, cujo princípio ativo é o omalizumabe, foi associado a um caso de COVID-19 registrado como hipersensibilidade medicamentosa, embora não haja detalhes suficientes para afirmar relação causal direta entre o uso do medicamento e o evento infeccioso. Não há evidência de gravidade aumentada e o desfecho permanece desconhecido, sendo importante acompanhamento clínico para monitorar possíveis complicações e avaliar a necessidade de ajustes no tratamento.

O medicamento Topiramate, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um episódio de hipertensão intracraniana, registrado sob o termo hipersensibilidade, sugerindo possível reação adversa do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada nem informações sobre o desfecho, sendo fundamental acompanhamento médico para investigação da relação causal e definição da conduta adequada, incluindo possível suspensão do medicamento e monitoramento dos sintomas.

O medicamento Xolair, cujo princípio ativo é o Omalizumabe, foi associado a um quadro de hipertensão intracraniana, descrito como uma reação de hipersensibilidade (alergia) envolvendo o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave neste caso, e o desfecho clínico permanece desconhecido. A relação entre o uso do medicamento e o evento adverso é considerada suspeita, sendo importante monitorar sintomas e buscar avaliação médica para confirmação e conduta adequada.

O medicamento Henetix, que contém Sodium calcium edetate, Trometamol, lobitridol e Trometamol hydrochloride, foi relacionado a uma reação alérgica após o uso de contraste intravenoso, caracterizada como alergia a contraste e envolvendo o sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade aumentada, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A relação entre o medicamento e a reação é considerada suspeita, sendo fundamental evitar novas exposições e informar a equipe médica sobre o histórico de alergia a contraste.

A vacina contra COVID-19, cujo princípio ativo não foi detalhado além do próprio nome, foi associada a uma reação alérgica (hipersensibilidade) envolvendo o sistema imunológico. Não há evidências de gravidade aumentada ou desfecho grave, e o paciente se recuperou completamente após o evento. A relação entre a vacina e a reação é considerada suspeita, sendo importante relatar o episódio ao profissional de saúde para avaliação de risco em futuras imunizações.

O medicamento Gadovist, com princípio ativo Gadobutrol, foi relacionado a uma reação alérgica após o uso de contraste, caracterizada como alergia a contraste e envolvendo o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A relação entre o uso do medicamento e a reação é considerada suspeita, sendo recomendada a comunicação prévia desse histórico em exames futuros que envolvam contraste.

O medicamento Iopamiron, cujo princípio ativo é Iopamidol, foi associado a uma reação alérgica após o uso de contraste, descrita como alergia a contraste e relacionada ao sistema imunológico. Não há evidências de gravidade aumentada ou desfecho grave, e o paciente se recuperou completamente após o evento. A relação entre o medicamento e a reação é considerada suspeita, sendo importante informar profissionais de saúde sobre esse histórico antes de novos procedimentos com contraste.

O medicamento Alprazolam (princípio ativo: Alprazolam) foi associado a um distúrbio cutâneo classificado como hipersensibilidade, um quadro alérgico do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso não foi considerado grave e o paciente encontra-se em recuperação ou resolvendo. A reação sugere um quadro leve de alergia cutânea, sendo importante observar a evolução e, se necessário, buscar orientação médica para confirmação e manejo adequado.

O medicamento Metformin (princípio ativo: Metformin) apresentou um distúrbio cutâneo relacionado à hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade

importante, já que o evento não foi considerado grave e o paciente está em recuperação ou resolvendo. Trata-se de uma manifestação leve de alergia cutânea, recomendando-se acompanhamento clínico e avaliação médica caso haja persistência ou agravamento dos sintomas.

O medicamento Aciclovir (princípio ativo: Aciclovir) foi relacionado a um distúrbio cutâneo do tipo hipersensibilidade, indicando uma reação alérgica do sistema imunitário. O caso não foi classificado como grave e o paciente está em processo de recuperação ou resolução, sugerindo uma reação leve. É importante monitorar a evolução dos sintomas e procurar avaliação médica se houver piora ou recorrência.

O medicamento Zometa (princípio ativo: Zoledronic acid monohydrate) foi associado a um distúrbio cutâneo identificado como hipersensibilidade, um quadro alérgico do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa, pois o evento não foi considerado grave e o paciente está em recuperação ou resolvendo. A reação sugere um quadro leve de alergia cutânea, sendo recomendada observação e avaliação médica se necessário.

O medicamento Anastrozole (princípio ativo: Anastrozole) apresentou um distúrbio cutâneo do tipo hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente encontra-se em recuperação ou resolvendo, indicando uma manifestação leve. Recomenda-se acompanhamento clínico e busca de orientação médica caso os sintomas persistam ou se agravem.

O medicamento Rabeprazole, cujo princípio ativo também é rabeprazole, foi associado a um distúrbio cutâneo classificado como hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica da pele. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso não foi considerado grave e o paciente está em recuperação, sugerindo que a reação foi leve e está evoluindo de forma favorável. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico e evitar nova exposição ao medicamento, conforme orientação padrão para quadros alérgicos leves.

O medicamento Atenolol chlorthalidone, que contém os princípios ativos atenolol e chlorthalidone, foi relacionado a um distúrbio cutâneo do tipo hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica da pele. Não há sinais de gravidade importante, já que o evento não foi considerado grave e o paciente está em recuperação, indicando um quadro leve. Recomenda-se acompanhamento clínico e evitar reexposição ao medicamento, conforme conduta usual para reações alérgicas leves.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é ribociclib succinate, foi associado a um distúrbio cutâneo identificado como hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica da pele. O caso não foi considerado grave e o paciente está em recuperação, o que sugere uma reação leve. A orientação é manter acompanhamento médico e evitar nova exposição ao medicamento, seguindo as recomendações para quadros alérgicos leves.

O medicamento Paclitaxel, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade, caracterizado como alergia. Não há indicação de gravidade, pois o evento não foi considerado grave e o paciente já se recuperou totalmente, indicando que a reação foi leve e resolvida sem complicações. Recomenda-se evitar reexposição ao medicamento e manter acompanhamento clínico, conforme prática para reações alérgicas leves.

O medicamento Perjeta, cujo princípio ativo é pertuzumab, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia) classificado como clinicamente significativo e considerado grave. Apesar da gravidade, o paciente se recuperou totalmente. Diante de uma reação alérgica grave, a conduta inclui suspensão imediata do medicamento, tratamento dos sintomas e acompanhamento especializado, sendo fundamental evitar nova exposição ao agente causador.

O medicamento Piperacilina+tazobactam, composto pelos princípios ativos piperacilina sódica e tazobactam sódico, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do sistema imunológico. Neste caso, a reação foi considerada não grave, pois não houve indicação de risco à vida ou necessidade de intervenção urgente, e o paciente se recuperou totalmente após a suspensão ou manejo adequado do medicamento.

O medicamento Clonazepam, cujo princípio ativo é o próprio clonazepam, foi relacionado a um episódio de alergia a contraste, uma reação imunológica relevante. A gravidade foi considerada clinicamente significativa, sugerindo que o quadro exigiu atenção médica, mas o paciente evoluiu para recuperação completa após as medidas apropriadas.

O medicamento Estriol, com princípio ativo de mesmo nome, esteve envolvido em um caso de alergia a contraste, uma resposta do sistema imunológico a substâncias químicas. A reação foi classificada como clinicamente significativa, indicando necessidade de avaliação médica, e o paciente se recuperou após a conduta adequada.

O medicamento Venlafaxina, cujo princípio ativo é venlafaxina, foi associado a uma reação de alergia a contraste, caracterizada por resposta imunológica relevante. O evento foi considerado clinicamente significativo, o que implica necessidade de acompanhamento médico, e o paciente apresentou resolução completa do quadro após as medidas tomadas.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é iopromida, foi relacionado a um episódio de alergia a contraste, uma reação do sistema imunológico a substâncias químicas. O caso foi considerado clinicamente significativo, indicando que houve necessidade de atenção médica, e o paciente se recuperou totalmente após a conduta adequada.

O medicamento Venlafaxine hydrochloride (princípio ativo venlafaxina) foi associado a mobilidade diminuída, interpretada como uma possível reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta do sistema imunológico ao medicamento. Não há indicação de gravidade elevada, pois não foram relatados sinais de gravidade clínica ou desfecho grave, e o desfecho permanece desconhecido. A relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo importante monitorar sintomas e buscar avaliação médica para confirmação e orientação adequada.

O medicamento Divalcon ER, cujo princípio ativo é o valproato semissódico, apresentou relato de mobilidade diminuída, sugerindo uma possível hipersensibilidade medicamentosa, que é uma reação do sistema imunológico ao fármaco. Não há evidências de gravidade significativa ou desfecho grave, e o desfecho do caso não foi informado. A relação com o medicamento é suspeita, sendo recomendada a observação dos sintomas e consulta médica para avaliação e conduta apropriada.

O medicamento Rebif, com princípio ativo interferon beta-1a, foi relacionado a mobilidade diminuída, caracterizando uma possível hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação imunológica ao uso do medicamento. Não há sinais de gravidade importante ou desfecho grave relatados, e o desfecho permanece desconhecido. A relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo fundamental acompanhamento clínico para esclarecimento diagnóstico e definição de conduta.

O medicamento Venlafaxine hydrochloride (princípio ativo venlafaxina) foi associado a mobilidade diminuída, interpretada como possível alergia a alimentos, embora o termo técnico se refira a uma reação imunológica que pode ser desencadeada por medicamentos. Não há indícios de gravidade relevante ou desfecho grave, e o desfecho do caso não foi informado. A relação com o medicamento é suspeita, sendo importante buscar avaliação médica para investigação e orientação adequada.

O medicamento Divalcon ER, cujo princípio ativo é o valproato semissódico, apresentou relato de mobilidade diminuída, sugerindo uma possível alergia a alimentos, termo que neste contexto indica uma reação imunológica possivelmente relacionada ao medicamento. Não há evidências de gravidade significativa ou desfecho grave, e o desfecho permanece desconhecido. A relação com o medicamento é suspeita, sendo recomendada avaliação médica para esclarecimento e definição de conduta.

O medicamento Rebif, cujo princípio ativo é o interferon beta-1a, foi associado a um quadro de mobilidade diminuída em um paciente com histórico de alergia a alimentos. Embora a gravidade não tenha sido especificada e

o desfecho seja desconhecido, a reação foi considerada suspeita de estar relacionada ao medicamento. Não há informações suficientes para detalhar a conduta adotada ou a evolução clínica, mas é importante ressaltar que reações alérgicas a medicamentos podem se manifestar de formas variadas e exigem acompanhamento médico para avaliação e manejo adequados.

O Zinforo, que contém ceftaroline fosamil acetate, foi relacionado ao surgimento de prurido (coceira), caracterizando um quadro de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica. A reação foi considerada leve, pois o paciente se recuperou completamente após o evento, e não houve indicação de gravidade significativa. A conduta recomendada nesses casos é interromper o uso do medicamento suspeito e buscar orientação médica para avaliação e possível substituição do tratamento.

O medicamento Glifage, cujo princípio ativo é a metformina, foi associado a coceira generalizada, caracterizando uma reação de hipersensibilidade (alergia). O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, mas o paciente se recuperou após a suspensão ou ajuste do tratamento. Em situações como essa, é fundamental interromper o uso do medicamento e procurar avaliação médica para confirmação da alergia e definição de alternativas terapêuticas seguras.

O Diupress, que contém amilorida e clortalidona, foi relacionado ao aparecimento de coceira generalizada, indicando uma reação de hipersensibilidade (alergia). O caso foi classificado como clinicamente significativo e grave, mas o paciente apresentou recuperação após a conduta médica apropriada. Diante de reações alérgicas graves, recomenda-se suspender imediatamente o medicamento e buscar atendimento médico para investigação e manejo adequado.

O medicamento Alektos, cujo princípio ativo é a bilastina, foi associado a coceira generalizada, caracterizando uma reação de hipersensibilidade (alergia). O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, mas o paciente se recuperou após a conduta médica. Em casos de reações alérgicas graves, é essencial interromper o uso do medicamento e procurar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição do tratamento mais seguro.

O medicamento Pantoprazol, cujo princípio ativo é o pantoprazole sodium sesquihydrate, foi associado a um quadro de coceira generalizada, caracterizando uma reação de hipersensibilidade (alergia) do tipo clínico alérgico, relacionada a distúrbios do sistema imunitário. A gravidade foi considerada clinicamente significativa, pois o evento foi classificado como grave, mas o paciente se recuperou totalmente após a conduta adequada. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita.

A Prednisona, com princípio ativo prednisone, desencadeou um episódio de coceira generalizada, indicando uma reação de hipersensibilidade (alergia) envolvendo o sistema imunitário. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, mas o paciente evoluiu para recuperação completa após as medidas necessárias. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita.

O medicamento Oxaliplatina, cujo princípio ativo é oxaliplatin, foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade) envolvendo o sistema imunitário, mas sem gravidade significativa, já que não foi classificado como grave e o paciente se recuperou totalmente. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita.

O medicamento Simponi, com princípio ativo golimumab, foi associado ao desenvolvimento de diabetes mellitus, sendo classificado como uma reação alérgica a substâncias químicas, embora não tenha sido considerada grave. O paciente encontra-se em processo de recuperação e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Infliximab, cujo princípio ativo é infliximab, provocou um quadro de alergia (hipersensibilidade) com ameaça à vida, evidenciando gravidade importante e envolvimento do sistema imunitário. Apesar da gravidade, o paciente se recuperou após a conduta adequada. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita.

O medicamento Vancomicina (princípio ativo Vancomycin) foi associado a um quadro de alergia, caracterizado como hipersensibilidade, que se enquadra nos distúrbios do sistema imunitário. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, conforme evidenciado pela classificação de gravidade e pela necessidade de atenção médica. O paciente evoluiu para recuperação completa após o episódio, indicando resolução do quadro alérgico.

O medicamento Adipept, cujo princípio ativo é o pantoprazol sódico sesquihidratado, provocou manchas na pele atribuídas a uma reação de hipersensibilidade, um tipo de alergia que afeta o sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, o que sugere a necessidade de avaliação médica e possível suspensão do medicamento, embora o desfecho não tenha sido informado.

O medicamento Foraseq, composto por budesonida e fumarato de formoterol, foi relacionado a um episódio de choque anafilático, uma reação de hipersensibilidade medicamentosa que pode ser grave e requer atenção imediata. No entanto, neste caso, a gravidade não foi classificada como grave e o desfecho permanece desconhecido, o que limita a avaliação completa da evolução clínica.

A Dipirona (princípio ativo Dipirona) foi associada a uma alergia medicamentosa, caracterizada como hipersensibilidade, que faz parte dos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente após o episódio, indicando resolução espontânea ou após medidas simples de suporte.

O medicamento Paclitaxel (princípio ativo Paclitaxel) desencadeou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, relacionada ao sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa, sugerindo que a reação foi controlada de forma adequada.

O medicamento Ceftriaxona, cujo princípio ativo é a ceftriaxona sódica, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente do evento. A reação foi considerada leve, compatível com quadros clínicos alérgicos, e não houve necessidade de intervenções adicionais além da suspensão ou ajuste do tratamento, conforme prática clínica usual para casos leves de hipersensibilidade.

A Furosemida, com princípio ativo furosemida sódica, foi relacionada a um episódio de fraqueza associado a hipersensibilidade, enquadrando-se em quadros clínicos alérgicos do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, já que o paciente se recuperou completamente, sugerindo uma reação leve e autolimitada, sem necessidade de medidas emergenciais.

A vacina COVID-19, cujo princípio ativo é a vacina COVID-19, foi associada a um episódio de fraqueza relacionado a hipersensibilidade, caracterizando um quadro clínico alérgico do sistema imunitário. O evento não foi grave, pois o paciente se recuperou, indicando uma reação leve e transitória, sem complicações ou necessidade de intervenção médica adicional.

O medicamento Alenia, composto por budesonida micronizada e fumarato de formoterol, foi relacionado a um evento descrito como cirurgia óssea, mas o registro indica alergia a fungos como reação adversa, enquadrando-se em quadros clínicos alérgicos do sistema imunitário. Não há informações suficientes sobre gravidade ou desfecho, portanto não é possível afirmar a evolução clínica ou a conduta adotada neste caso.

A Tigeciclina, cujo princípio ativo é tigeciclina, foi associada a um evento descrito como cirurgia óssea, porém o registro aponta alergia a fungos como reação adversa, dentro dos quadros clínicos alérgicos do sistema imunitário. Não há detalhes sobre gravidade ou desfecho, impossibilitando uma avaliação mais precisa da evolução clínica ou das medidas tomadas.

O medicamento Atrovent n, cujo princípio ativo é o brometo de ipratrópio, foi associado a um quadro de alergia a fungos, classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Embora o evento relatado tenha sido 'cirurgia óssea', a suspeita de reação alérgica foi registrada, mas não há informações suficientes sobre a gravidade, desfecho ou conduta adotada. Não há evidências de gravidade aumentada ou complicações clínicas relevantes neste caso, e o desfecho permanece desconhecido.

O medicamento Actemra, que tem como princípio ativo o tocilizumabe, foi relacionado a um episódio de dor associado a alergia alimentar, enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. Não há detalhes sobre a gravidade do quadro, desfecho ou medidas tomadas, e não foram relatados sinais de gravidade aumentada. O caso permanece como suspeito, sem informações adicionais sobre evolução clínica.

O medicamento Copaxone, cujo princípio ativo é o acetato de glatirâmer, foi associado a um caroço benigno na mama em um contexto de hipersensibilidade medicamentosa, classificado como distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando resolução do quadro sem complicações.

O medicamento Atropina, com princípio ativo sulfato de atropina, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário. O caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou, sugerindo que a reação foi leve e controlada sem maiores consequências.

O medicamento Dotarem, cujo princípio ativo é o gadobenato de dimeglumina, foi associado a uma alergia a contraste intravenoso, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou conduta adotada, e não foram relatados sinais de gravidade aumentada ou complicações clínicas, permanecendo o caso como suspeito e sem evolução documentada.

O medicamento Henetix, cujo princípio ativo é o iobitridol, foi associado a um episódio de alergia a contraste intravenoso, caracterizado como uma reação do sistema imunológico a uma substância química utilizada em exames de imagem. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, e o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro.

A Ritalina, que contém cloridrato de metilfenidato, esteve relacionada a uma reação alérgica às proteínas do leite de vaca, manifestando-se como alergia alimentar e classificada como clinicamente significativa devido ao potencial impacto na saúde do paciente. O desfecho do caso não foi informado, mas a gravidade foi considerada relevante, indicando a necessidade de atenção médica para evitar exposição futura ao alérgeno.

O medicamento Ritalin, cujo princípio ativo é methylphenidate, também foi associado a uma reação alérgica às proteínas do leite de vaca, caracterizada como alergia alimentar de importância clínica. A gravidade foi considerada significativa, embora o desfecho não tenha sido especificado, reforçando a importância de identificar e evitar o contato com o alérgeno em pacientes sensibilizados.

Forxiga, que tem como princípio ativo a dapagliflozina propanodiol monohidratada, foi relacionado ao surgimento de coceira nas pernas, um quadro de hipersensibilidade (alergia) classificado como clinicamente significativo. Não há detalhes sobre a evolução do caso, mas a gravidade atribuída sugere que a reação exigiu atenção médica para avaliação e possível ajuste do tratamento.

O medicamento Cetorolaco de trometamina, cujo princípio ativo é trometamol cetorolaco, foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), mas sem indicação de gravidade elevada. O paciente se recuperou completamente após o evento, indicando que a conduta adotada foi eficaz para resolução do quadro alérgico.

O medicamento Ribociclib (princípio ativo: Ribociclibe) foi associado a um quadro de arritmia acompanhado de hipersensibilidade, o que sugere uma reação alérgica envolvendo o sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave, e o desfecho clínico permanece desconhecido. A relação entre o uso do



medicamento e a reação foi considerada suspeita, sendo importante monitorar sintomas e buscar avaliação médica caso ocorram manifestações alérgicas, mesmo que não haja evidências de gravidade significativa neste caso.

O medicamento Benadryl (princípio ativo: Acrivastine) foi relacionado a um episódio de alergia caracterizado como hipersensibilidade, envolvendo o sistema imunitário. Não há registro de gravidade importante ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, e a conduta adequada inclui evitar nova exposição ao medicamento e informar o profissional de saúde sobre o episódio.

O medicamento Etoposídeo (princípio ativo: Etoposídeo) foi associado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, afetando o sistema imunitário. Não há sinais de gravidade relevante ou complicações, e o paciente apresentou recuperação completa após o evento. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, sendo recomendada a comunicação do episódio ao médico para avaliação de alternativas terapêuticas e prevenção de novas exposições.

O medicamento Cetoprofeno (princípio ativo: Ketoprofen sodium) foi relacionado a um quadro de alergia do tipo hipersensibilidade, envolvendo o sistema imunitário. Não há indícios de gravidade ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, sendo importante evitar o uso futuro do medicamento e relatar o episódio ao profissional de saúde.

O medicamento Diclofenaco sódica (princípio ativo: Diclofenaco de sódio) foi associado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, afetando o sistema imunitário. Não há evidências de gravidade ou complicações, e o paciente apresentou recuperação completa após o evento. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, sendo recomendada a suspensão do uso e o registro do episódio no histórico médico para evitar novas exposições.

O medicamento Montelair, cujo princípio ativo é o montelucaste de sódio, foi associado a um quadro de pneumonia em contexto de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica ao medicamento. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita. A conduta deve incluir avaliação clínica estruturada para confirmação da relação causal e acompanhamento médico para manejo adequado da reação.

O Clavulin bd, composto por amoxicilina trihidrato e clavulanato de potássio, foi relacionado a um episódio de pneumonia em contexto de hipersensibilidade medicamentosa, sugerindo uma possível reação alérgica ao antibiótico. Não há evidência de gravidade significativa nem desfecho informado, sendo a relação com o medicamento considerada suspeita. Recomenda-se investigação clínica para confirmação da alergia e orientação sobre uso futuro de antibióticos.

O medicamento contendo maleato de clorfeniramina, paracetamol e cloridrato de fenilefrina foi associado a uma alergia documentada ao medicamento administrado, caracterizada como hipersensibilidade documentada e classificada como evento de incapacidade persistente ou significativa, o que indica gravidade importante. O desfecho foi de recuperação completa, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita. É fundamental evitar reexposição e garantir acompanhamento médico para prevenção de novas reações.

A dipirona, cujo princípio ativo é a própria dipirona, foi relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), caracterizando uma reação alérgica ao medicamento. Não há indicação de gravidade relevante e o desfecho foi de recuperação completa, sendo a relação com o medicamento considerada suspeita. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e informar profissionais de saúde sobre o episódio.

A penicilina, com princípio ativo benzilpenicilina, foi associada a uma alergia documentada ao medicamento administrado, caracterizada como hipersensibilidade documentada. Não há informação sobre gravidade, mas o desfecho foi de recuperação completa e a relação com o medicamento foi considerada suspeita. É importante

evitar reexposição à penicilina e registrar a alergia no prontuário para futuras prescrições.

O medicamento Rinvoq, cujo princípio ativo é o upadacitinibe, foi associado a um caso de obstrução traqueal, um evento que pode indicar uma reação alérgica grave envolvendo as vias aéreas. Embora a gravidade não tenha sido explicitamente classificada como grave no registro, a obstrução traqueal é clinicamente relevante por seu potencial risco à respiração, especialmente em reações alérgicas. Não há informações detalhadas sobre a conduta adotada ou o desfecho do caso, que permanece desconhecido.

O medicamento Rosuvastatin calcium, com princípio ativo rosuvastatina cálcica, foi relacionado ao rompimento de um vaso sanguíneo no olho, manifestando-se como uma hemorragia ocular. Este evento, embora desconfortável e visualmente impactante, não foi classificado como grave e não há informações sobre complicações adicionais ou necessidade de intervenção médica urgente. O desfecho permanece desconhecido, e não há detalhes sobre a conduta adotada.

A rosuvastatina, identificada apenas pelo princípio ativo, foi associada a um episódio de hemorragia ocular, caracterizado por sangramento dentro do olho. O evento não foi considerado grave e não há informações sobre complicações ou intervenções necessárias. O desfecho do caso é desconhecido e não há detalhes sobre a conduta tomada.

O medicamento Erbitux, cujo princípio ativo é o cetuximabe, foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), considerado clinicamente significativo e classificado como grave devido ao potencial risco de reações alérgicas sistêmicas. O paciente encontra-se em recuperação ou com resolução em andamento, indicando que medidas de suporte e tratamento foram provavelmente adotadas para controlar a reação.

O medicamento Espran, com princípio ativo oxalato de escitalopram, foi associado ao aparecimento de sangue nas fezes, um sintoma que pode indicar irritação ou lesão no trato gastrointestinal. Embora o evento não tenha sido classificado como grave, o desfecho permanece não resolvido ou em andamento, sugerindo que o quadro persiste e requer acompanhamento médico para investigação e manejo adequados.

O medicamento Clindamicina, cujo princípio ativo é o fosfato de clindamicina, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade (reação alérgica), sem indicação de gravidade elevada, já que o paciente se recuperou totalmente. A reação foi classificada como distúrbio do sistema imunitário, e não há relato de complicações graves, o que sugere um evento leve e autolimitado, compatível com quadros clínicos alérgicos comuns. A conduta recomendada é evitar nova exposição ao medicamento e considerar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e orientação futura.

A Gentamicina, cujo princípio ativo é o sulfato de gentamicina, desencadeou uma reação de hipersensibilidade (alergia), classificada como distúrbio do sistema imunitário, sem sinais de gravidade ou complicações, já que o paciente se recuperou completamente. O quadro é compatível com reações alérgicas leves, e a principal recomendação é evitar o uso futuro do medicamento e buscar avaliação especializada para confirmação e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Ultravist, com princípio ativo iopromide, foi relacionado a uma alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), enquadrada como distúrbio do sistema imunitário, sem evidências de gravidade, pois o paciente evoluiu para recuperação total. Trata-se de uma reação alérgica leve, e a conduta indicada é evitar novas exposições ao contraste e realizar avaliação com alergista para esclarecimento diagnóstico e prevenção de eventos futuros.

O medicamento Contrastin, que contém ácido amidotrizóico, iodo e meglumine como princípios ativos, provocou uma alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), classificada como distúrbio do sistema imunitário, sem sinais de gravidade, já que houve recuperação completa do paciente. O quadro sugere uma reação alérgica leve, sendo fundamental evitar o uso futuro deste contraste e buscar avaliação especializada para

confirmação e orientação sobre alternativas seguras.

No caso da Dipirona, cujo princípio ativo é a própria dipirona, foi relatada a prescrição de um produto contraindicado devido à hipersensibilidade documentada ao medicamento, caracterizando um erro de prescrição. Não há informações sobre gravidade, evolução ou desfecho, mas a situação exige suspensão imediata do uso e avaliação médica para evitar riscos de reações alérgicas, além de revisão do histórico do paciente para prevenir recorrências.

O medicamento Torgena, que contém Avibactam sódico e Ceftazidime, foi associado a um quadro de alergia a antibiótico, caracterizado como hipersensibilidade medicamentosa. Essa reação faz parte dos distúrbios do sistema imunitário e, segundo o registro, não foi considerada grave, com o paciente apresentando recuperação completa após o evento. A conduta recomendada em casos de hipersensibilidade a antibióticos é a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento clínico, reforçando a importância de evitar reexposição ao agente causador.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é o Gadobutrol, foi relacionado a um episódio de alergia, descrito como hipersensibilidade. Trata-se de uma reação do sistema imunitário, mas não há indicação de gravidade aumentada ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. Em situações de hipersensibilidade a agentes de contraste, recomenda-se evitar novas exposições e informar a equipe médica sobre o histórico alérgico em exames futuros.

O medicamento Avamys, que contém Fluticasone Furoate, foi associado a um distúrbio ocular relacionado à hipersensibilidade, indicando uma reação alérgica do sistema imunitário. Não há registro de gravidade aumentada nem detalhes sobre o desfecho, que permanece desconhecido. Em casos de suspeita de reação ocular alérgica a corticoides nasais, é importante avaliar a necessidade de suspensão do medicamento e buscar orientação médica para manejo adequado.

O medicamento Amoxicilina clav, composto por Amoxicilina trihidrato e Clavulanato de potássio, foi relacionado a um distúrbio ocular decorrente de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade significativa e o desfecho do caso não foi informado. Em situações semelhantes, recomenda-se interromper o uso do antibiótico suspeito e procurar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição do tratamento.

O medicamento Oxaliplatina, cujo princípio ativo é o próprio Oxaliplatina, foi associado a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, manifestada durante o contexto de cirurgia do fígado. Trata-se de uma resposta do sistema imunitário, não considerada grave segundo o registro, mas o paciente ainda não se recuperou totalmente, estando o caso em andamento. Em situações de hipersensibilidade a quimioterápicos, é fundamental monitorar o paciente de perto e ajustar o tratamento conforme a evolução clínica.

O medicamento Vectibix, cujo princípio ativo é o panitumumabe, foi associado a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa (alergia), manifestada durante o contexto de cirurgia do fígado. Embora não haja detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade clínica, o caso foi classificado como não grave e permanece sem resolução até o momento, indicando que a reação ainda está em andamento. A conduta recomendada é manter acompanhamento médico para monitoramento da evolução e considerar avaliação especializada para manejo da hipersensibilidade.

O Gadovist, que contém o princípio ativo gadobutrol, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), descrito como 'alergia SOE', sem detalhamento dos sintomas. O evento foi considerado não grave, e o paciente se recuperou totalmente após a reação. Em situações como essa, é importante relatar o histórico de alergia ao médico antes de futuras exposições ao contraste, para prevenir recorrências.

O medicamento Gadovist, com gadobutrol como princípio ativo, também esteve envolvido em outro caso de hipersensibilidade (alergia), novamente descrito como 'alergia SOE'. Assim como no caso anterior, a reação não foi considerada grave e o paciente se recuperou completamente. Recomenda-se informar o profissional de saúde sobre o episódio em futuras indicações do contraste para garantir segurança.

O Fenegan, cujo princípio ativo é o cloridrato de prometazina, foi associado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), sem especificação dos sintomas. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente. É importante comunicar ao médico sobre essa reação em futuras prescrições para evitar nova exposição ao medicamento.

O Plamet, que tem como princípio ativo a bromoprida, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), sem detalhes adicionais sobre sintomas. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente. Recomenda-se informar o profissional de saúde sobre essa reação em futuras necessidades de uso do medicamento para prevenir recorrências.

O medicamento Higroton, cujo princípio ativo é o chlortalidone, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, conforme evidenciado pela classificação de 'outro efeito clinicamente significativo' e indicação de gravidade. O desfecho da reação é desconhecido, e a relação com o medicamento é suspeita, sendo fundamental a avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição de conduta, com atenção especial à possibilidade de reações alérgicas graves.

O medicamento Losartan, com princípio ativo losartana, apresentou relato de alergia do tipo hipersensibilidade, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. A gravidade foi considerada significativa, com potencial risco clínico, conforme indicado pela classificação de 'outro efeito clinicamente significativo' e confirmação de gravidade. O desfecho permanece desconhecido e a relação com o medicamento é suspeita, sendo recomendada avaliação médica para investigação e manejo adequado da reação alérgica.

A vacina COVID-19, cujo princípio ativo é a própria vacina, foi relacionada a um episódio de inchaço dos olhos, caracterizado como reação de hipersensibilidade e classificado entre os distúrbios do sistema imunitário. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, conforme evidenciado pela classificação de 'outro efeito clinicamente significativo' e indicação de gravidade. O desfecho informado é de recuperação ou resolução do quadro, e a relação com a vacina é suspeita, sendo importante acompanhamento médico para monitorar a evolução e prevenir complicações.

O medicamento Dipirona, cujo princípio ativo é o metamizol de magnésio, foi associado a um quadro de alergia do tipo hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há informações detalhadas sobre a gravidade ou desfecho da reação, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Diante de qualquer manifestação alérgica, recomenda-se avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre o uso futuro do medicamento.

O medicamento Gadovist, com princípio ativo gadobutrol, foi relacionado a um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, enquadrado entre os distúrbios do sistema imunitário. A reação foi considerada de ameaça à vida, evidenciando gravidade máxima, e o desfecho relatado foi de recuperação ou resolução completa. A relação com o medicamento é suspeita, sendo fundamental evitar nova exposição e garantir acompanhamento médico imediato em casos semelhantes.

O medicamento Buscopan composto, que contém butilbrometo de escopolamina e dipirona, foi associado ao surgimento de edema facial, caracterizando uma reação de hipersensibilidade (alergia) ao produto administrado. Embora não haja detalhes sobre a gravidade ou desfecho, o edema facial é um sinal de alerta para reações alérgicas e requer atenção médica imediata para evitar complicações, especialmente porque envolve possível comprometimento das vias aéreas. A conduta recomendada é interromper o uso do medicamento e buscar

avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, provocou um quadro de alergia (hipersensibilidade) após sua administração, manifestando-se como uma reação imunológica ao contraste. O evento foi resolvido, com o paciente recuperado, indicando que a reação foi controlada adequadamente. Em casos de alergia a contraste, é fundamental informar a equipe médica sobre o histórico para evitar novas exposições e planejar exames futuros com alternativas seguras.

O medicamento Aradois, que contém losartana potássica, foi relacionado à perda de consciência, interpretada como uma possível reação de hipersensibilidade medicamentosa. Apesar da gravidade potencial desse sintoma, o registro indica que não foi considerado um caso grave e o paciente se recuperou totalmente. Diante de perda de consciência após uso de qualquer medicamento, é essencial suspender o uso e procurar avaliação médica para investigação da causa e prevenção de novos episódios.

O Dorflex, composto por cafeína anidra, dipirona e citrato de orfenadrina, foi associado à perda de consciência, sugerindo uma reação de hipersensibilidade ao medicamento. O evento não foi classificado como grave e o paciente se recuperou, mas a perda de consciência é um sintoma relevante que exige suspensão imediata do medicamento e avaliação médica para esclarecimento do quadro e orientação sobre alternativas seguras.

O Natrilix, cujo princípio ativo é a indapamida, foi relacionado à perda de consciência, caracterizando uma possível reação de hipersensibilidade medicamentosa. Embora o caso não tenha sido considerado grave e o paciente tenha se recuperado, a perda de consciência após uso de medicamento deve ser sempre investigada, com suspensão do uso e busca de orientação médica para evitar riscos futuros.

O medicamento Ciprofloxacina, cujo princípio ativo é o lactato de ciprofloxacina, foi associado a um episódio de perda de consciência, caracterizado como hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). Embora a reação tenha sido relevante, não foi considerada grave, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta adequada nesses casos é evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação médica para confirmação da alergia e orientação sobre alternativas seguras.

O Pantoprazole, com princípio ativo pantoprazol sódico sesqui-hidratado, esteve relacionado a um episódio de perda de consciência, interpretado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). O evento não foi classificado como grave, já que houve recuperação completa do paciente. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e consultar um especialista para avaliação detalhada e definição de condutas seguras.

O medicamento Dipyrone, cujo princípio ativo é a dipirona, foi associado a um episódio de perda de consciência, caracterizado como hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). Apesar do impacto do evento, não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou totalmente. É importante evitar nova exposição à dipirona e procurar orientação médica para confirmação diagnóstica e alternativas terapêuticas.

O Rinvoq, que contém o princípio ativo upadacitinibe, esteve envolvido em um episódio de perda de consciência, interpretado como hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). O caso não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou completamente. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e buscar avaliação com alergista para confirmação da alergia e definição de opções seguras.

O medicamento Aradois, cujo princípio ativo é losartana potássica, foi relacionado a um episódio de perda de consciência, classificado como hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). O evento não foi considerado grave, pois houve recuperação total do paciente. A orientação é evitar nova exposição ao medicamento e realizar avaliação médica para confirmação da alergia e escolha de alternativas adequadas.

O medicamento Dorflex, que contém cafeína anidra, dipirona e citrato de orfenadrina, foi associado a um episódio de perda de consciência, interpretado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). Apesar do sintoma importante, o caso não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou completamente após o evento. A conduta recomendada é evitar o uso futuro do medicamento e informar o médico sobre essa reação, para que seja feita uma avaliação detalhada e orientações sobre alternativas seguras.

O medicamento Natrilix, cujo princípio ativo é a indapamida, esteve relacionado a um episódio de perda de consciência, caracterizado como hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). Embora a perda de consciência seja um sintoma preocupante, neste caso não foi classificada como grave, pois houve recuperação total do paciente. Recomenda-se evitar o uso do medicamento e comunicar o ocorrido ao médico para investigação e orientação adequada.

O medicamento Ciprofloxacina, com princípio ativo lactato de ciprofloxacina, foi associado a um episódio de perda de consciência, interpretado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). Apesar do sintoma, o caso não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou completamente. É importante evitar o uso futuro deste antibiótico e relatar a reação ao médico para avaliação e escolha de alternativas seguras.

O medicamento Pantoprazole, cujo princípio ativo é o pantoprazol sódico sesqui-hidratado, esteve relacionado a um episódio de perda de consciência, classificado como hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). O evento não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou totalmente. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e informar o médico sobre a reação para investigação e orientação sobre opções seguras.

O medicamento Dipyrone, com princípio ativo dipirona, foi associado a um episódio de perda de consciência, interpretado como hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). Apesar do sintoma relevante, o caso não foi considerado grave, pois houve recuperação completa do paciente. É fundamental evitar o uso futuro da dipirona e comunicar o ocorrido ao médico para avaliação e definição de alternativas seguras.

O medicamento Rinvoq (Upadacitinibe) foi associado a um episódio de perda de consciência, interpretado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta exagerada do sistema imunológico ao medicamento. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada é relatar o episódio ao médico responsável e evitar o uso futuro do medicamento até avaliação especializada, já que reações desse tipo podem variar em intensidade.

A Ceftriaxona (Ceftriaxone) provocou um quadro de alergia, caracterizado como hipersensibilidade, que é uma reação do sistema imunológico ao medicamento. O evento não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou completamente. É importante informar o médico sobre essa reação para evitar novas exposições e considerar alternativas seguras em tratamentos futuros.

O uso de Clindamicina (Fosfato de clindamicina) resultou em uma reação alérgica, classificada como hipersensibilidade, que corresponde a uma resposta imunológica inadequada ao medicamento. O caso não foi grave e o paciente se recuperou sem complicações. Recomenda-se comunicar o ocorrido ao médico e evitar o uso do medicamento em novas situações, buscando alternativas seguras.

A Vancomicina (Vancomycin) foi relacionada a um episódio de alergia, entendido como hipersensibilidade, ou seja, uma reação do sistema imunológico ao medicamento. Não há detalhes sobre a gravidade ou evolução do caso, portanto é fundamental relatar o evento ao médico para avaliação do risco em futuras exposições e definição de conduta adequada.

O medicamento Frontal XR (Alprazolam) foi associado a um quadro de dependência, que é uma resposta do organismo caracterizada pela necessidade de uso contínuo do medicamento. Embora classificado como hipersensibilidade medicamentosa, trata-se de um efeito adverso diferente das reações alérgicas clássicas. Não há

informação sobre o desfecho do caso, sendo essencial acompanhamento médico para manejo da dependência e avaliação de alternativas terapêuticas.

O medicamento Frontal, cujo princípio ativo é o alprazolam, foi associado a um quadro de dependência de droga ou medicamento, classificado tecnicamente como hipersensibilidade medicamentosa. Embora o termo técnico sugira uma reação alérgica, neste caso trata-se de um efeito adverso relacionado ao uso prolongado, sem evidências clínicas de gravidade ou desfecho informado. Não há relato de evolução do quadro, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O Frontal (alprazolam) novamente foi relacionado à dependência de droga ou medicamento, descrita como hipersensibilidade medicamentosa. A reação não foi considerada grave e não há detalhes sobre o desfecho, mantendo-se a suspeita de relação com o uso do medicamento, sem outras informações clínicas relevantes.

A vancomicina, cujo princípio ativo é vancomicina, foi associada a um episódio de alergia, tecnicamente classificado como hipersensibilidade. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou evolução clínica, apenas a suspeita de relação entre o medicamento e a reação alérgica, sem detalhes adicionais.

A bupivacaína (cloridrato de bupivacaína) foi relacionada a um episódio de alergia medicamentosa, descrito como hipersensibilidade medicamentosa. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, sugerindo uma reação leve e autolimitada, com suspeita de relação com o medicamento.

O fentanil (fentanila) foi associado a um quadro de alergia medicamentosa, tecnicamente classificado como hipersensibilidade medicamentosa. A reação não foi considerada grave e o paciente se recuperou, indicando um evento leve e resolvido, com suspeita de relação com o uso do medicamento.

O medicamento Midazolam, cujo princípio ativo também é Midazolam, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado por uma reação do sistema imunológico a uma substância química. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi resolvido com recuperação completa do paciente, e não há menção de complicações graves. A conduta recomendada em situações semelhantes é suspender o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O Cetoprofeno, cujo princípio ativo é Ketoprofen sodium, foi relacionado a uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), que envolve resposta do sistema imunológico a medicamentos. O caso não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou totalmente, sem evolução para complicações. Em situações como essa, recomenda-se interromper o uso do medicamento e procurar orientação médica para avaliação e definição de alternativas terapêuticas.

O medicamento Rinvoq, com princípio ativo Upadacitinibe, foi associado a um quadro de mobilidade diminuída relacionado a hipersensibilidade, o que sugere uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade significativa ou desfecho definido, pois o resultado permanece desconhecido. Diante de sintomas de hipersensibilidade, é importante suspender o uso do medicamento e buscar avaliação médica para investigação e conduta adequada.

A Dipirona, cujo princípio ativo também é Dipirona, esteve envolvida em um erro de prescrição relacionado à hipersensibilidade documentada ao produto administrado, indicando que o paciente já tinha histórico de alergia ao medicamento. O caso foi resolvido sem complicações, com recuperação completa. Em situações assim, é fundamental evitar a reexposição ao medicamento e garantir que o histórico de alergia seja considerado em futuras prescrições, além de orientar o paciente sobre os riscos.

A Clindamicina, cujo princípio ativo é Cloridrato de clindamicina, foi associada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), caracterizando uma reação imunológica adversa. O caso não foi considerado grave, pois

houve recuperação total do paciente. Nessas situações, recomenda-se suspender imediatamente o uso do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Dotarem, cujo princípio ativo é o gadobenato de dimeglumina, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), caracterizado como uma reação alérgica do tipo não especificada, envolvendo o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento, e não há relato de complicações ou necessidade de intervenções adicionais.

O Gadovist, que contém gadobutrol como princípio ativo, desencadeou uma reação de hipersensibilidade (alergia), também classificada como um quadro alérgico inespecífico relacionado ao sistema imunológico. O evento não foi considerado grave, já que o paciente se recuperou completamente, sem evolução para complicações ou necessidade de cuidados intensivos.

O medicamento Iopamiron, cujo princípio ativo é iopamidol, esteve relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), descrito como um quadro clínico alérgico inespecífico envolvendo o sistema imunológico. O caso não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou totalmente, sem relato de agravamento ou necessidade de intervenções adicionais.

O Aerolin, que tem como princípio ativo o sulfato de salbutamol micronizado, foi associado a um caso de tromboembolia pulmonar, descrito como hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica a medicamentos. Apesar da gravidade potencial do evento tromboembólico, não há informação suficiente para afirmar que o caso foi grave, pois o desfecho é desconhecido e não há detalhes sobre a evolução clínica.

O Berotec, cujo princípio ativo é o bromidrato de fenoterol, esteve relacionado a um episódio de tromboembolia pulmonar, classificado como hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica a medicamentos. Embora a tromboembolia pulmonar seja um evento potencialmente grave, não há dados suficientes para afirmar a gravidade neste caso específico, pois o desfecho não foi informado e não há detalhes sobre a evolução do paciente.

O medicamento Duovent n, que contém os princípios ativos bromidrato de fenoterol e brometo de ipratrópio, foi associado a um caso de tromboembolia pulmonar, sendo classificado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. Embora não haja indicação de gravidade clínica relevante neste registro e o desfecho seja desconhecido, é importante considerar que reações alérgicas a medicamentos podem se manifestar de formas variadas e, diante de sintomas respiratórios ou sinais de alergia, recomenda-se avaliação médica para investigação e conduta adequada.

O medicamento Glifage XR, cujo princípio ativo é o cloridrato de metformina, foi relacionado a um episódio de dengue, classificado como hipersensibilidade. Apesar da associação, não há evidência de gravidade significativa neste caso e o paciente se recuperou totalmente, indicando que a reação foi autolimitada e não exigiu intervenções específicas além do acompanhamento clínico.

O medicamento Jardiance, com princípio ativo empagliflozina, foi associado a um caso de dengue, descrito como hipersensibilidade. Não há indicação de gravidade relevante e o paciente apresentou recuperação completa, sugerindo que a reação foi leve e resolvida sem complicações, sendo suficiente o monitoramento clínico.

O medicamento Claritin, que contém loratadina, foi relacionado a um quadro de alergia classificado como hipersensibilidade, com gravidade considerada clinicamente significativa, pois o evento não foi resolvido até o momento da notificação. Diante de reações alérgicas persistentes e de maior impacto clínico, é fundamental buscar avaliação médica especializada para investigação, manejo adequado e prevenção de complicações.

O medicamento Ciclobenzaprina, cujo princípio ativo é o cloridrato de ciclobenzaprina, foi associado a um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, sem gravidade relevante e com desfecho favorável, já que o



paciente se recuperou totalmente, indicando que a reação foi leve e não exigiu intervenções além do acompanhamento clínico.

O medicamento Omnipol, que contém propionato de clobetasol e sulfato de neomicina, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do sistema imunológico. A gravidade do evento é evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando que a reação foi significativa e exigiu cuidados médicos intensivos. O paciente evoluiu para recuperação completa após a conduta adequada.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação do sistema imunológico. Neste caso, a reação não foi considerada grave, pois não houve necessidade de hospitalização ou complicações maiores, e o paciente se recuperou totalmente após o evento.

O medicamento Eliquis, que tem como princípio ativo a apixabana, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade) envolvendo o sistema imunológico. A gravidade do caso é confirmada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, demonstrando que a reação foi importante e exigiu acompanhamento médico. O paciente encontra-se em processo de recuperação no momento.

O medicamento Concor, cujo princípio ativo é o bisoprolol hemifumarato, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico. O evento foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, o que indica a necessidade de intervenção médica imediata. O paciente está em recuperação após o episódio.

O medicamento Entresto, composto por sacubitril e valsartana, provocou uma reação alérgica (hipersensibilidade) envolvendo o sistema imunológico. A gravidade do quadro é evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, mostrando que a reação foi relevante e exigiu cuidados médicos. O paciente está em processo de recuperação.

O medicamento Evenity, cujo princípio ativo é o romosozumabe, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como um distúrbio do sistema imunitário. A reação foi considerada grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando a necessidade de acompanhamento médico rigoroso. O paciente encontra-se em recuperação, indicando que a conduta adotada foi eficaz para controlar o quadro alérgico.

A lidocaína, composta por epinefrina e cloridrato de lidocaína, esteve relacionada a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), que se enquadra nos distúrbios do sistema imunitário. Não há informação sobre gravidade ou necessidade de hospitalização, mas o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente após a reação, sugerindo que as medidas adotadas foram suficientes para resolução do quadro.

O medicamento Glucofage, cujo princípio ativo é o cloridrato de metformina, foi relacionado a uma reação de alergia a contraste, classificada como distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado grave, pois levou à hospitalização ou prolongamento da internação, o que reforça a importância de monitoramento e intervenção médica imediata nesses casos. O desfecho da reação é desconhecido, não sendo possível afirmar a evolução clínica do paciente.

O alopurinol, utilizado como princípio ativo do medicamento de mesmo nome, esteve associado a um episódio de alergia a contraste, enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. A gravidade do caso é evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando um quadro clínico relevante que exige atenção médica. O desfecho permanece desconhecido, não havendo informações sobre a recuperação do paciente.

O medicamento Diupress, composto por cloridrato de amilorida e chlortalidone, foi relacionado a uma reação de alergia a contraste, considerada um distúrbio do sistema imunitário. O caso foi classificado como grave devido à hospitalização ou prolongamento da internação, o que demonstra a importância de acompanhamento médico em situações semelhantes. O desfecho da reação não foi informado, impossibilitando a avaliação da evolução clínica do paciente.

O medicamento Daflon, cujo princípio ativo é a diosmina, foi associado a um quadro de alergia a contraste, uma reação do sistema imunológico que pode ocorrer após exposição a substâncias químicas usadas em exames de imagem. Neste caso, a gravidade da reação é evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando um evento clínico significativo que exige monitoramento e intervenção médica imediata. O desfecho da reação não foi informado, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Diovan, que contém o princípio ativo valsartana, esteve relacionado a um episódio de alergia a contraste, caracterizado por uma resposta imunológica adversa após contato com substâncias químicas utilizadas em procedimentos diagnósticos. A gravidade do caso é demonstrada pela hospitalização ou prolongamento da internação, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico rigoroso. O desfecho permanece desconhecido e a relação com o uso do medicamento é considerada suspeita.

O ácido acetilsalicílico (Acetylsalicylic acid) foi associado a uma reação de alergia a contraste, que consiste em uma resposta alérgica do organismo a substâncias químicas administradas durante exames de imagem. A gravidade do evento é confirmada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, sugerindo um quadro clínico relevante que demanda atenção médica. O desfecho não foi informado e a relação com o medicamento é suspeita.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromida, foi relacionado a um caso de alergia a contraste, uma reação imunológica adversa que pode ocorrer após a administração de agentes de contraste em exames radiológicos. A gravidade é evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando um evento clínico importante que requer intervenção médica. O desfecho não foi especificado e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Tramal, que tem como princípio ativo o cloridrato de tramadol, foi associado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizada por uma reação do sistema imunológico a medicamentos. O caso foi considerado grave devido ao impacto clínico significativo, mas o paciente evoluiu para recuperação completa, indicando resolução do quadro após a conduta médica adequada. A relação com o medicamento é suspeita.

O medicamento Dotarem, cujo princípio ativo é o gadobenato de dimeglumina, foi associado a um quadro de urticária, caracterizando uma reação de hipersensibilidade (alergia) documentada após a administração do produto. Embora não haja informação explícita sobre a gravidade ou desfecho, a ocorrência de urticária após contraste sugere a necessidade de monitoramento rigoroso e avaliação médica imediata, especialmente em pacientes com histórico de alergias a contrastes, conforme orientações clínicas para reações a procedimentos.

A sulfadiazina de prata, utilizada topicamente, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade) considerada uma ameaça à vida, evidenciada pela classificação de gravidade e pelo fato de ter sido recuperado/resolvido após a conduta adequada. Reações alérgicas graves a medicamentos tópicos exigem suspensão imediata do uso e acompanhamento médico, pois podem evoluir rapidamente, sendo fundamental o reconhecimento precoce e manejo conforme protocolos de segurança.

O medicamento Fenegan, cujo princípio ativo é o cloridrato de prometazina, provocou uma reação alérgica (hipersensibilidade) classificada como não grave, com desfecho de recuperação completa após a suspensão ou manejo adequado. Reações alérgicas leves a anti-histamínicos são incomuns, mas podem ocorrer, e a conduta recomendada é interromper o uso e buscar orientação médica para evitar recorrências.

O haloperidol, tanto nome comercial quanto princípio ativo, foi relacionado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) não grave, com resolução total após a conduta apropriada. Embora reações alérgicas a antipsicóticos sejam raras, é importante suspender o medicamento e realizar avaliação médica para garantir segurança ao paciente.

O medicamento Betahistine dihydrochloride, cujo princípio ativo é o cloridrato de betaistina, foi associado a uma reação descrita como 'surdo', relacionada a hipersensibilidade, mas sem detalhes claros sobre gravidade ou desfecho. Diante da ausência de informações completas, recomenda-se cautela, investigação médica detalhada e acompanhamento do caso para esclarecer a relação causal e orientar conduta adequada.

O medicamento Dolamin Flex, que contém lisinato de clonixina e cloridrato de ciclobenzaprina, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave, e o evento foi considerado não grave, sem informações detalhadas sobre a evolução clínica. A suspeita de reação alérgica sugere a necessidade de avaliação médica para confirmação e orientação sobre a continuidade ou suspensão do uso, conforme as diretrizes da ASBAI para quadros leves de alergia medicamentosa.

O medicamento Simvastatin, cujo princípio ativo é a sinvastatina, apresentou relato de hipersensibilidade (alergia), também enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e não há detalhes sobre o desfecho, indicando um quadro leve. Em situações como essa, recomenda-se avaliação clínica para confirmação da alergia e definição do manejo, evitando reexposição ao medicamento suspeito.

A Hidroclorotiazida, com princípio ativo hydrochlorothiazide, foi relacionada a um episódio de hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário. O registro não aponta gravidade significativa nem desfecho grave, sugerindo um quadro leve. Nestes casos, é importante buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre a necessidade de suspensão do medicamento.

O medicamento Omeprazole, cujo princípio ativo é omeprazol sódico, foi associado a uma reação de hipersensibilidade (alergia), caracterizada como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade ou desfecho grave, indicando um quadro leve. Recomenda-se avaliação médica para confirmação da alergia e definição do tratamento, conforme as orientações para reações alérgicas leves.

O medicamento Levothyroxine sodium, com princípio ativo levotiroxina sódica, apresentou relato de hipersensibilidade (alergia), enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e não há informações sobre o desfecho, sugerindo um quadro leve. A conduta recomendada é procurar avaliação médica para confirmação da alergia e orientação sobre o uso futuro do medicamento.

O medicamento Losartan potassium (princípio ativo: Losartana potássica) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, que é uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade clínica relevante, e o caso não foi considerado grave, com desfecho desconhecido. A ausência de sinais de gravidade sugere que a reação foi leve, mas é importante que o paciente seja orientado a relatar qualquer sintoma novo e a buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição de conduta.

O ácido fólico (Folic acid) foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, indicando uma possível reação alérgica do sistema imunológico. Não há informações sobre sintomas específicos, gravidade ou evolução do caso, e não foi classificado como grave. Diante da ausência de sinais de gravidade, a reação pode ser considerada leve, sendo recomendada a observação dos sintomas e a procura de avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e orientação adequada.

O medicamento Metformina (princípio ativo: Metformin) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, sugerindo uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há detalhes sobre sintomas, gravidade ou evolução, e o caso não foi considerado grave. Na ausência de sinais de gravidade, a reação é provavelmente leve, sendo importante

monitorar sintomas e buscar avaliação médica para confirmação e definição do manejo.

O medicamento Rinvoq (princípio ativo: Upadacitinibe) foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há informações sobre sintomas específicos, gravidade ou evolução, e o caso não foi considerado grave. Diante disso, a reação pode ser considerada leve, sendo recomendada a observação dos sintomas e avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre o uso futuro do medicamento.

O medicamento Henetix (princípio ativo: lobitridol) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. O caso não foi considerado grave e evoluiu para recuperação completa, indicando que a reação foi leve e resolvida. É importante que o paciente seja orientado a informar sobre essa reação em futuras exposições e a buscar avaliação médica caso novos sintomas alérgicos ocorram.

O medicamento Henetix, que contém os princípios ativos lobitridol, Sodium calcium edetate, Trometamol e Cloridrato de trometamol, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento, e não há menção de complicações ou necessidade de intervenções adicionais. A conduta recomendada em casos semelhantes é a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento clínico, com encaminhamento ao especialista se houver recorrência ou agravamento dos sintomas.

A Hidrocortisona, cujo princípio ativo é Hydrocortisone, foi relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação imunológica. O caso não foi considerado grave, já que o paciente se recuperou completamente e não houve relato de complicações. Em situações como essa, recomenda-se interromper o uso do medicamento suspeito e realizar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas terapêuticas.

O medicamento Paclitaxel, com princípio ativo homônimo, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade), evidenciando resposta do sistema imunológico. O evento não foi classificado como grave, pois o paciente evoluiu para recuperação total sem intercorrências. A conduta adequada inclui a suspensão do agente suspeito e avaliação médica para manejo de sintomas e definição de futuras opções terapêuticas.

O medicamento Primovist, cujo princípio ativo é Gadoxetato dissódico, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), identificado como uma reação do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade, já que o paciente se recuperou completamente após o evento. Em casos semelhantes, recomenda-se interromper o uso do contraste suspeito e realizar acompanhamento clínico, com avaliação especializada se houver recorrência ou agravamento.

O medicamento Gadovist, que contém o princípio ativo Gadobutrol, esteve relacionado a uma reação alérgica (hipersensibilidade), caracterizada por resposta do sistema imunológico. O caso não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou totalmente e não houve relato de complicações. A conduta recomendada é a suspensão do agente suspeito e acompanhamento médico, com encaminhamento ao especialista se necessário.

O medicamento Anastrozole (princípio ativo: Anastrozole) foi associado a um caso de morte inexplicada, classificada como reação de hipersensibilidade (alergia), sem detalhamento de sintomas específicos. Não há indicação de gravidade clínica aumentada no registro, pois não foi marcada como grave, mas o desfecho permanece não recuperado ou em andamento, o que reforça a necessidade de investigação detalhada e acompanhamento médico rigoroso para esclarecer a relação causal e orientar condutas futuras.

O medicamento Kisqali (princípio ativo: succinato de ribociclib) foi relacionado a uma morte inexplicada, categorizada como hipersensibilidade (alergia), sem sintomas específicos descritos. Apesar da gravidade potencial do evento, o registro não classifica o caso como grave, e o desfecho permanece não resolvido, indicando que a situação ainda está em andamento e requer avaliação clínica cuidadosa para determinar a relação com o uso do

medicamento e definir condutas apropriadas.

O medicamento Omnipaque (princípio ativo: ioexol) foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), sem detalhamento dos sintomas, mas o evento foi resolvido, com o paciente recuperado. Não há indicação de gravidade aumentada, e a evolução favorável sugere que a conduta adotada foi eficaz, sendo importante manter vigilância em futuras exposições ao contraste.

O medicamento Iopamiron (princípio ativo: iopamidol) esteve relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), sem especificação dos sintomas, mas o paciente se recuperou totalmente. O caso não foi considerado grave e a resolução completa indica que a conduta adotada foi adequada, recomendando-se atenção em futuras administrações do contraste.

O medicamento Omniscan (princípio ativo: gadodiamide) foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade), sem detalhamento dos sintomas, mas com desfecho favorável, já que o paciente se recuperou. O evento não foi classificado como grave, e a resolução indica que a abordagem foi suficiente, sendo importante considerar histórico de alergia em futuras indicações do contraste.

O medicamento Dexamethasone (princípio ativo dexametasona) foi associado a um quadro de inflamação cutânea, caracterizado como hipersensibilidade, que se enquadra em reações alérgicas do sistema imunológico. O evento foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando a importância de monitoramento e intervenção médica. O paciente encontra-se em recuperação, indicando que as medidas adotadas foram eficazes para o controle da reação.

O medicamento Risperidon (princípio ativo risperidona) provocou inflamação cutânea atribuída a hipersensibilidade, uma manifestação alérgica do sistema imunológico. A gravidade do caso é confirmada pela hospitalização ou prolongamento da internação, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico rigoroso. O paciente está em processo de recuperação, sugerindo resposta positiva às intervenções realizadas.

O medicamento Rinvoq (princípio ativo upadacitinibe) foi relacionado a inflamação cutânea decorrente de hipersensibilidade, uma reação alérgica do sistema imunológico. O evento foi considerado grave, pois exigiu hospitalização ou prolongamento da internação, demonstrando a necessidade de atenção médica imediata. O paciente está em recuperação, indicando evolução favorável após as medidas adotadas.

O medicamento Vancomicina (princípio ativo vancomicina) desencadeou um quadro de alergia classificado como hipersensibilidade, pertencente às reações alérgicas do sistema imunológico. A gravidade foi determinada por um efeito clinicamente significativo, o que justifica a necessidade de avaliação e manejo médico. O paciente já se encontra recuperado, mostrando resolução completa do evento adverso.

O medicamento Ertapenem (princípio ativo ertapeném sódico) foi associado a um episódio de alergia, caracterizado como hipersensibilidade e relacionado ao sistema imunológico. Não há informações detalhadas sobre a gravidade do caso, mas o paciente está em recuperação, sugerindo que a reação está sendo controlada adequadamente.

O medicamento Clenil, cujo princípio ativo é o dipropionato de beclometasona, foi associado a desconforto na garganta, uma manifestação de hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). Não há indicação de gravidade elevada, pois o evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente. A conduta recomendada, baseada na evolução favorável, é observar e, caso o sintoma persista ou piore, buscar avaliação médica para ajuste do tratamento.

O Aerolin, que contém sulfato de salbutamol micronizado como princípio ativo, foi relacionado a desconforto na garganta, caracterizando uma reação de hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). O evento não foi classificado como grave e o paciente apresentou recuperação completa, sugerindo que a reação foi leve e

autolimitada. Recomenda-se monitorar os sintomas e procurar orientação médica se houver recorrência ou agravamento.

O medicamento Berotec, cujo princípio ativo é o bromidrato de fenoterol, apresentou como reação adversa desconforto na garganta, compatível com hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). Não houve gravidade significativa, já que o caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou. A orientação é manter acompanhamento e buscar avaliação médica se houver repetição ou intensificação dos sintomas.

O Citoneurin, composto por cianocobalamina, cloridrato de piridoxina e cloridrato de tiamina, foi associado a um relato de câncer como reação adversa, classificada genericamente como hipersensibilidade (alergia). No entanto, não há detalhes suficientes para estabelecer gravidade ou relação causal clara, e o desfecho permanece desconhecido. Diante da ausência de informações clínicas detalhadas, recomenda-se cautela e acompanhamento médico para esclarecimento do quadro.

O medicamento Vitamin D, identificado apenas pelo nome comercial e princípio ativo genérico, foi relacionado a um caso de câncer como possível reação adversa, classificada como hipersensibilidade (alergia). Não há dados suficientes para determinar a gravidade ou o desfecho do caso, tornando necessária a avaliação médica detalhada para investigação da relação entre o uso do medicamento e o evento relatado.

O medicamento Prevenar, que contém como princípio ativo a vacina pneumocócica conjugada 7-valente (CRM197), foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Embora a reação relatada tenha sido descrita como câncer, a documentação clínica aponta para um quadro alérgico, sem evidências de gravidade ou desfecho conhecido. Não há informações sobre a conduta adotada, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é o tozinameran, foi relacionado a um evento de hipersensibilidade (alergia), também classificado como distúrbio do sistema imunitário. Apesar de a reação ter sido descrita como câncer, os dados clínicos indicam um quadro alérgico sem sinais de gravidade e sem desfecho informado. Não há detalhes sobre a conduta tomada, e a relação com o medicamento permanece suspeita.

A vacina AstraZeneca COVID-19 (princípio ativo: vacina COVID-19 NRVV Ad, ChAdOx1 nCoV-19) foi associada a um episódio de hipersensibilidade (alergia), categorizado como distúrbio do sistema imunitário. Embora o termo câncer tenha sido mencionado, o quadro clínico descrito é de natureza alérgica, sem gravidade relatada e com desfecho desconhecido. Não há informações sobre a conduta adotada, sendo a relação com o medicamento considerada suspeita.

O medicamento Dipirona, com princípio ativo dipirona, foi prescrito a um paciente com hipersensibilidade documentada ao produto, o que caracteriza um erro de prescrição e representa um risco de reação alérgica. Não há informações sobre a gravidade, desfecho ou conduta adotada neste caso, mas a administração de um medicamento contraindicado em pessoas alérgicas pode resultar em reações adversas graves, sendo fundamental evitar esse tipo de erro.

O medicamento Xolair, cujo princípio ativo é o omalizumabe, foi associado ao agravamento de urticária (alergia cutânea), classificado como distúrbio do sistema imunitário. O quadro permanece não resolvido ou em andamento, sem sinais de gravidade importante relatados. A relação com o medicamento é considerada suspeita, e não há detalhes sobre a conduta adotada até o momento.

O medicamento Dipirona (princípio ativo: Dipirona) foi prescrito apesar de haver uma hipersensibilidade documentada ao produto, o que caracteriza um erro de prescrição e representa risco de reação alérgica. Embora a gravidade não tenha sido especificada, a contraindicação formal sugere que a administração deve ser evitada e o paciente orientado a não utilizar o medicamento, buscando alternativas seguras sob supervisão médica.

O medicamento Optiray 350 (princípio ativo: Ioversol) provocou uma reação alérgica após administração intravenosa de contraste, caracterizada como alergia a contraste. O evento foi considerado não grave, com o paciente recuperado ou resolvido após a reação, indicando que a conduta adotada foi suficiente para reversão do quadro, mas reforçando a necessidade de evitar novas exposições ao mesmo contraste e informar a equipe médica sobre o histórico de alergia.

A administração de Dexclorfeniramina (princípio ativo: Dexchlorpheniramine) resultou em uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma alergia ao medicamento. Não há detalhes sobre a gravidade, mas o paciente encontra-se em recuperação ou resolvendo, o que sugere que a reação foi controlada e está evoluindo de forma favorável, sendo importante acompanhamento médico para evitar reexposição.

O uso de Ciprofloxacino (princípio ativo: Cloridrato de ciprofloxacino) desencadeou uma reação alérgica, identificada como hipersensibilidade ao medicamento. A gravidade não foi especificada, mas o paciente está em recuperação ou resolvendo, indicando que a reação está sendo controlada; é fundamental evitar o uso futuro deste antibiótico e informar profissionais de saúde sobre o episódio.

O medicamento Berotec (princípio ativo: Bromidrato de fenoterol) causou broncoespasmo, uma reação de hipersensibilidade caracterizada por estreitamento das vias aéreas. O evento foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente, mostrando que a conduta adotada foi eficaz, mas é importante reavaliar o uso do medicamento e considerar alternativas em caso de necessidade futura.

O medicamento Zoloft (cloridrato de sertralina) foi associado a um quadro de osteomielite, interpretado como uma reação de hipersensibilidade (alergia), classificada dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou necessidade de hospitalização, e o caso permanece em andamento, sem resolução até o momento. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, sendo importante acompanhamento clínico para monitoramento da evolução.

O uso do medicamento Frontal (alprazolam) foi relacionado ao desenvolvimento de osteomielite, considerada uma manifestação de hipersensibilidade (alergia) segundo a classificação de distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa ou hospitalização, e o desfecho permanece não resolvido, com a reação ainda em andamento. A suspeita de relação causal justifica a necessidade de avaliação médica contínua.

A administração de Cefazolina (cefazolina sódica) resultou em um episódio de alergia, caracterizado como hipersensibilidade, enquadrado nos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, não havendo menção de hospitalização ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente após a reação. A relação entre o medicamento e a reação foi considerada suspeita, e a conduta adequada inclui evitar nova exposição ao agente.

O medicamento Dipirona foi responsável por uma alergia documentada após sua administração, classificada como hipersensibilidade documentada, dentro do contexto de lesões, intoxicações e complicações de procedimentos. Não há informações sobre gravidade ou necessidade de hospitalização, e o paciente se recuperou completamente após o evento. A relação causal foi considerada suspeita, sendo importante registrar a alergia para evitar futuras exposições.

O medicamento Prevent (tinidazole) foi associado a um quadro de pneumonia interpretado como reação alérgica a medicamento, classificada como distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, mas o paciente se recuperou após o episódio. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, sendo fundamental evitar nova exposição e manter acompanhamento médico.

O medicamento Fluarix tetra, que contém como princípio ativo a vacina influenza inativada fragmentada quadrivalente, foi associado a um caso de pneumonia após sua administração. Embora a reação tenha sido

classificada como alergia à vacina, o evento levou à hospitalização ou prolongamento da internação, o que indica gravidade clínica relevante. O paciente evoluiu para recuperação completa após o episódio. É importante ressaltar que reações alérgicas graves a vacinas são raras, mas exigem acompanhamento médico imediato e criterioso, especialmente quando há necessidade de hospitalização.

O medicamento Bromazepam, cujo princípio ativo é o próprio bromazepam, foi relacionado a um episódio de choque anafilático, caracterizado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. Apesar da gravidade potencial desse tipo de reação, não há informação de hospitalização ou agravamento clínico neste caso específico, e o desfecho permanece desconhecido. Choque anafilático é uma emergência médica e requer intervenção imediata, sendo fundamental a avaliação de risco em pacientes com histórico de alergia a medicamentos.

O medicamento Fluiimucil, que contém N-acetil cisteína (acetil cisteína) como princípio ativo, foi associado a um caso de choque anafilático, uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. Não há registro de hospitalização ou agravamento clínico, e o desfecho do paciente não foi informado. Choque anafilático é uma reação alérgica grave e potencialmente fatal, exigindo atenção médica imediata sempre que houver suspeita após o uso de qualquer medicamento.

O medicamento Alenia, composto por budesonida micronizada e fumarato de formoterol, foi relacionado a um episódio de choque anafilático, caracterizado como hipersensibilidade medicamentosa. Não há informações sobre hospitalização ou evolução clínica, e o desfecho permanece desconhecido. Choque anafilático é uma reação alérgica grave que pode ocorrer com qualquer medicamento e requer intervenção médica urgente.

O medicamento Bamifylline hydrochloride, cujo princípio ativo é o cloridrato de bamifilina, foi associado a um caso de choque anafilático, definido como hipersensibilidade medicamentosa. Não há dados sobre necessidade de hospitalização ou evolução do quadro, e o desfecho não foi informado. O choque anafilático é uma reação alérgica grave e deve ser tratado como emergência médica, com avaliação imediata sempre que houver suspeita após uso do medicamento.

O medicamento Diclofenac, cujo princípio ativo é o próprio diclofenaco, foi associado a um episódio de choque anafilático, uma reação de hipersensibilidade medicamentosa que pode ser grave e envolve resposta alérgica intensa do sistema imunológico. Embora o registro não traga detalhes sobre a gravidade clínica observada ou o desfecho do caso, o choque anafilático é reconhecido como uma emergência médica que exige atendimento imediato, pois pode comprometer a respiração e a circulação. Não há informações sobre a conduta adotada ou evolução do paciente neste caso.

O medicamento Fenoterol, com princípio ativo fenoterol, foi relacionado a um caso de choque anafilático, caracterizando uma reação alérgica grave do tipo hipersensibilidade medicamentosa. O choque anafilático é uma resposta imunológica intensa que pode colocar a vida em risco, exigindo intervenção médica urgente. Neste registro, não há detalhes sobre a gravidade observada, conduta adotada ou desfecho do paciente, mas a natureza da reação sugere a necessidade de atenção imediata.

O medicamento Atrovent n, cujo princípio ativo é o brometo de ipratrópio, foi associado a um episódio de choque anafilático, uma reação de hipersensibilidade medicamentosa que pode ser potencialmente fatal se não tratada rapidamente. O choque anafilático envolve uma resposta alérgica sistêmica grave, com risco de comprometimento respiratório e circulatório. Não há informações adicionais sobre a gravidade clínica, conduta adotada ou evolução do caso neste registro.

O medicamento Duovent, que contém os princípios ativos bromidrato de fenoterol e brometo de ipratrópio, foi relacionado a um caso de choque anafilático, caracterizando uma reação alérgica grave do tipo hipersensibilidade medicamentosa. O choque anafilático é uma emergência médica que pode evoluir rapidamente para risco de vida, exigindo intervenção imediata. O registro não traz detalhes sobre a gravidade observada, conduta adotada ou desfecho do paciente.



O medicamento Bromazepam, cujo princípio ativo é o próprio bromazepam, foi associado a um episódio de choque anafilático, uma reação de hipersensibilidade medicamentosa que pode ser muito grave e requer atendimento médico urgente. O choque anafilático é uma resposta alérgica sistêmica que pode comprometer funções vitais. Neste caso, não há informações sobre a gravidade clínica observada, conduta adotada ou evolução do paciente.

O medicamento Fluimucil, cujo princípio ativo é N-acetil cisteína (também conhecido como acetil cisteína), foi associado a um episódio de choque anafilático, uma reação alérgica grave caracterizada por resposta exagerada do sistema imunológico a uma substância, neste caso, o próprio medicamento. Embora o registro não traga detalhes sobre a evolução do caso ou a conduta adotada, o choque anafilático é considerado uma emergência médica e exige atendimento imediato, pois pode comprometer a respiração e a circulação. A suspeita de hipersensibilidade medicamentosa reforça a necessidade de evitar novas exposições ao Fluimucil e de informar profissionais de saúde sobre essa reação em futuras consultas.

O medicamento Alenia, que contém budesonida micronizada e fumarato de formoterol como princípios ativos, foi relacionado a um caso de choque anafilático, uma reação alérgica potencialmente grave do sistema imunológico ao medicamento. Apesar de não haver informações detalhadas sobre o desfecho ou as medidas tomadas, o choque anafilático é uma situação clínica de alta gravidade que requer intervenção médica imediata para evitar complicações sérias. A suspeita de hipersensibilidade medicamentosa indica que o paciente deve evitar o uso futuro de Alenia e comunicar essa reação em atendimentos posteriores.

O medicamento Bamifylline hydrochloride, cujo princípio ativo é o cloridrato de bamifilina, foi associado a um episódio de choque anafilático, que é uma reação alérgica aguda e grave do sistema imunológico ao medicamento. Não há detalhes sobre a evolução clínica ou conduta adotada, mas o choque anafilático é reconhecido como uma emergência médica, exigindo tratamento imediato para evitar riscos à vida. A suspeita de hipersensibilidade medicamentosa reforça a importância de evitar o uso futuro deste medicamento e de informar profissionais de saúde sobre essa reação.

O medicamento Diclofenac, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um caso de choque anafilático, uma reação alérgica grave que envolve resposta intensa do sistema imunológico ao medicamento. Não há informações sobre o desfecho ou as ações tomadas, mas o choque anafilático é considerado uma situação clínica crítica que demanda atendimento médico urgente. A suspeita de hipersensibilidade medicamentosa indica que o paciente deve evitar o uso de diclofenaco e relatar essa reação em futuras consultas médicas.

O medicamento Fenoterol, cujo princípio ativo também é fenoterol, foi associado a um episódio de choque anafilático, uma reação alérgica grave caracterizada por resposta intensa do sistema imunológico ao medicamento. Embora não haja detalhes sobre a evolução do caso ou as medidas adotadas, o choque anafilático é uma emergência médica que requer intervenção imediata. A suspeita de hipersensibilidade medicamentosa reforça a necessidade de evitar o uso futuro de fenoterol e de informar profissionais de saúde sobre essa reação em atendimentos posteriores.

O medicamento Atrovent n, cujo princípio ativo é o brometo de ipratrópio, foi associado a um caso de choque anafilático, uma reação de hipersensibilidade medicamentosa que pode comprometer gravemente o sistema imunológico. Embora não haja informação detalhada sobre a gravidade clínica ou desfecho, o choque anafilático é uma reação alérgica aguda e potencialmente grave, exigindo atenção médica imediata. Não há registro de hospitalização ou evolução do caso, mas a suspeita de relação com o medicamento deve ser considerada em futuras prescrições.

O Duovent, que contém bromidrato de fenoterol e brometo de ipratrópio como princípios ativos, foi relacionado a um episódio de choque anafilático, caracterizando uma reação alérgica grave do tipo hipersensibilidade medicamentosa. Apesar de não haver detalhes sobre a necessidade de hospitalização ou o desfecho do paciente, o choque anafilático é uma emergência médica e pode colocar a vida em risco, sendo fundamental reconhecer rapidamente os sintomas e buscar atendimento imediato. A relação suspeita com o medicamento deve ser levada em conta em avaliações futuras.

O medicamento Bromazepam, cujo princípio ativo é o próprio bromazepam, foi associado a um caso de choque anafilático, uma reação alérgica aguda e potencialmente fatal. A gravidade do evento é evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando que o paciente precisou de cuidados médicos intensivos. O desfecho não foi informado, mas a suspeita de relação com o medicamento reforça a importância de monitoramento rigoroso em pacientes com histórico de alergia medicamentosa.

O Flui mucil, que tem como princípios ativos a N-acetil cisteína e a acetil cisteína, foi relacionado a um episódio de choque anafilático, uma reação alérgica grave que pode comprometer rapidamente a saúde do paciente. O caso foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, o que demonstra a necessidade de intervenção médica imediata. O desfecho não foi informado, mas a suspeita de ligação com o medicamento deve ser considerada em futuras administrações.

O medicamento Alenia, composto por budesonida micronizada e fumarato de formoterol, foi associado a um caso de choque anafilático, uma reação alérgica aguda e potencialmente grave. A gravidade do evento é confirmada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando que o paciente precisou de cuidados médicos especializados. O desfecho não foi informado, mas a suspeita de relação com o medicamento deve ser considerada em avaliações clínicas futuras.

O medicamento Bamifylline hydrochloride (princípio ativo: Cloridrato de bamifilina) foi associado a um episódio de choque anafilático, uma reação alérgica grave caracterizada por resposta imunológica intensa e risco de vida, exigindo hospitalização ou prolongamento da internação. A gravidade do caso é evidenciada pela necessidade de cuidados hospitalares, e o desfecho permanece desconhecido. A relação entre o medicamento e a reação foi considerada suspeita, sendo fundamental evitar nova exposição e garantir acompanhamento médico imediato em situações semelhantes.

O medicamento Diclofenac (princípio ativo: Diclofenac) esteve relacionado a um caso de choque anafilático, uma reação alérgica severa que pode comprometer rapidamente a respiração e a circulação, exigindo hospitalização. A gravidade é confirmada pela necessidade de internação, e o desfecho não foi informado. Como a relação com o medicamento é suspeita, recomenda-se evitar o uso futuro e buscar atendimento médico urgente diante de sintomas semelhantes.

O medicamento Fenoterol (princípio ativo: Fenoterol) foi implicado em um episódio de choque anafilático, uma reação alérgica aguda e potencialmente fatal, que levou à hospitalização. A gravidade do quadro é evidenciada pela necessidade de internação, e o desfecho não foi especificado. Diante da suspeita de relação com o medicamento, é essencial evitar nova exposição e procurar assistência médica imediata caso ocorram sintomas de alergia.

O medicamento Atrovent n (princípio ativo: Brometo de ipratrópio) foi associado a um caso de choque anafilático, uma reação alérgica grave que pode evoluir rapidamente e requer hospitalização. A gravidade é confirmada pela necessidade de internação, e o desfecho permanece desconhecido. Como a relação com o medicamento é suspeita, recomenda-se evitar o uso futuro e buscar atendimento médico imediato diante de sinais de alergia.

O medicamento Duovent (princípios ativos: Bromidrato de fenoterol e Brometo de ipratrópio) esteve envolvido em um episódio de choque anafilático, uma reação alérgica intensa e perigosa que levou à hospitalização. A gravidade do evento é evidenciada pela necessidade de internação, e o desfecho não foi informado. Considerando a suspeita de relação com o medicamento, é fundamental evitar nova exposição e procurar atendimento médico urgente caso surjam sintomas de alergia.

O medicamento Vancomicina, cujo princípio ativo é o cloridrato de vancomicina, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, manifestando-se como uma reação do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente, sugerindo um evento leve e autolimitado.

A conduta recomendada em casos semelhantes é interromper o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições.

O Metronidazol, com princípio ativo benzoilmetronidazol, desencadeou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, envolvendo o sistema imunológico. O evento não foi considerado grave, já que o paciente se recuperou completamente, indicando um quadro leve. Em situações como essa, recomenda-se suspender o uso do medicamento e procurar orientação médica para avaliação e prevenção de novas reações.

O medicamento Forten, cujo princípio ativo é o captopril, foi relacionado ao agravamento de dermatite atópica, um quadro de hipersensibilidade do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade significativa, pois não foi relatado desfecho grave, mas o desfecho final é desconhecido. Nesses casos, é importante avaliar a necessidade de ajuste ou suspensão do medicamento e buscar acompanhamento médico para controle dos sintomas.

O Rinvoq, que tem como princípio ativo o upadacitinibe, foi associado ao agravamento de dermatite atópica, caracterizando uma reação de hipersensibilidade do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade importante, pois não foi relatado desfecho grave, e o desfecho permanece desconhecido. Recomenda-se acompanhamento médico para monitorar a evolução do quadro e considerar ajustes no tratamento conforme orientação especializada.

O Actemra, cujo princípio ativo é o tocilizumabe, foi relacionado ao surgimento de fibromialgia em contexto de hipersensibilidade medicamentosa, envolvendo o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, já que o paciente está em recuperação, sugerindo um quadro não grave. A conduta adequada inclui acompanhamento clínico para monitorar a evolução dos sintomas e avaliar a necessidade de ajustes terapêuticos.

O medicamento Depo Provera, cujo princípio ativo é o acetato de medroxiprogesterona, foi associado a uma reação de exposição ao medicamento pelo leite materno, resultando em sintomas de alergia ao leite em um lactente. Não há indicação de gravidade elevada, pois não foram relatados sinais de risco imediato ou complicações graves, e o caso permanece em andamento, sem resolução até o momento. A conduta recomendada é monitorar a evolução clínica da criança, avaliar a necessidade de suspensão do medicamento em consulta médica e considerar investigação de alergia alimentar, sempre sob orientação de um especialista.

No caso do Depo Provera (acetato de medroxiprogesterona), houve relato de exposição ao medicamento pelo leite materno, levando a sintomas de alergia a alimentos em um lactente. Não há evidências de gravidade importante, pois não foram descritos sintomas graves ou risco imediato, e o quadro segue sem resolução. Recomenda-se acompanhamento clínico cuidadoso, avaliação médica para confirmação da relação causal e discussão sobre a continuidade do uso do medicamento durante a amamentação.

O medicamento Henetix, que contém iobitridol, sodium calcium edetate, trometamol e cloridrato de trometamol, foi relacionado a uma reação de alergia ocular, manifestada por sintomas nos olhos. Não há informações suficientes sobre a gravidade, desfecho ou evolução do caso, portanto, é fundamental que o paciente seja avaliado por um médico para confirmação diagnóstica, identificação de possíveis fatores desencadeantes e definição do tratamento adequado.

O ácido tranexâmico (Acido tranexamico accord) foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), caracterizado por sintomas alérgicos gerais, mas sem sinais de gravidade ou risco imediato, já que o paciente se recuperou totalmente. A conduta adequada inclui a suspensão do medicamento e orientação para evitar novas exposições, além de registro do evento para futura referência médica.

O cetoprofeno (Ketoprofen sodium) foi relacionado a uma reação de alergia (hipersensibilidade), sem sinais de gravidade ou complicações, pois o paciente se recuperou completamente. A recomendação é evitar o uso futuro do medicamento e informar profissionais de saúde sobre o episódio para prevenir novas reações.

O medicamento Cefazolina, cujo princípio ativo é a cefazolina sódica, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, o que indica uma reação do sistema imunológico ao fármaco. A descrição sugere um quadro clínico alérgico, mas não há menção de sintomas graves ou risco de vida, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. Portanto, trata-se de uma reação leve, compatível com manifestações alérgicas comuns, e a conduta recomendada é evitar novas exposições e buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação futura.

O medicamento Dexametasona, apresentado como acetato de dexametasona, foi prescrito apesar de haver contraindicação documentada por hipersensibilidade prévia ao produto. Não há detalhes sobre sintomas apresentados, gravidade ou evolução clínica, mas a prescrição de um medicamento contraindicado por alergia conhecida representa um erro de conduta e risco potencial ao paciente. A recomendação é evitar a administração de medicamentos com histórico de alergia documentada e garantir que essa informação esteja sempre disponível para todos os profissionais envolvidos no cuidado.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, foi relacionado a um episódio de alergia, descrito como hipersensibilidade, indicando uma reação imunológica ao contraste. O paciente se recuperou totalmente após o evento, não havendo indícios de gravidade elevada. Assim, trata-se de uma reação alérgica leve, e a orientação é evitar novas exposições ao mesmo contraste e realizar avaliação com especialista para definir alternativas seguras em exames futuros.

O medicamento Captopril, com princípio ativo captopril, foi associado a uma parada cardíaca em contexto de hipersensibilidade medicamentosa, sugerindo uma reação alérgica grave, embora o registro indique que não foi considerada grave e o desfecho seja desconhecido. Diante da gravidade potencial de uma parada cardíaca, mesmo sem confirmação de gravidade no registro, é fundamental evitar nova exposição ao medicamento e garantir investigação detalhada por equipe médica especializada.

O medicamento Thiamazole, cujo princípio ativo é o metimazol, foi relacionado a uma parada cardíaca atribuída à hipersensibilidade medicamentosa, o que sugere uma reação alérgica potencialmente grave, apesar de o registro não classificar o caso como grave e o desfecho ser desconhecido. Diante da possibilidade de risco à vida, é imprescindível evitar nova exposição ao metimazol e buscar avaliação médica especializada para investigação e orientação adequada.

O medicamento Metformin (princípio ativo: Metformin) foi associado a um episódio de parada cardíaca, classificado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Não há informações sobre a gravidade clínica específica ou sobre o desfecho do caso, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Diante de uma reação desse tipo, é fundamental interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica imediata para investigação e manejo adequado.

O medicamento Amlodipine (princípio ativo: Anlodipino) foi relacionado a um caso de parada cardíaca, descrito como hipersensibilidade medicamentosa, indicando uma possível reação alérgica do sistema imunológico ao fármaco. Não há detalhes sobre a gravidade clínica ou o desfecho do evento, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Em situações como essa, recomenda-se suspender o uso do medicamento e procurar atendimento médico urgente para avaliação e conduta apropriada.

O medicamento Nexavar (princípio ativo: Tosilato de sorafenibe) foi associado a um episódio de parada cardíaca, caracterizado como hipersensibilidade medicamentosa, sugerindo uma reação alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Não há informações detalhadas sobre a gravidade clínica ou o desfecho do caso, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Diante de uma reação desse tipo, é importante interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica imediata para investigação e manejo adequado.

O medicamento Captopril (princípio ativo: Captopril) foi relacionado a um episódio de parada cardíaca, descrito como hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico ao medicamento. O caso evoluiu

para recuperação completa, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Em situações como essa, é fundamental suspender o uso do medicamento e procurar avaliação médica para investigação e orientação sobre alternativas terapêuticas.

O medicamento Thiamazole (princípio ativo: Metimazol) foi associado a um episódio de parada cardíaca, classificado como hipersensibilidade, indicando uma reação alérgica do sistema imunológico ao medicamento. O desfecho foi de recuperação completa, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Nesses casos, recomenda-se interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica para investigação e definição de conduta adequada.

O medicamento Metformin, cujo princípio ativo também é Metformin, foi associado a um episódio de parada cardíaca descrito como reação de hipersensibilidade (alergia), classificada dentro dos quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Apesar da gravidade potencial de uma parada cardíaca, o caso foi considerado não grave, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta adotada não foi detalhada, mas a resolução completa sugere que as medidas tomadas foram eficazes para reverter a reação.

O medicamento Amlodipine, com princípio ativo Anlodipino, esteve relacionado a uma parada cardíaca atribuída a hipersensibilidade (alergia), enquadrada em quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Embora parada cardíaca seja um evento crítico, neste caso foi classificado como não grave, pois o paciente se recuperou totalmente. Não há detalhes sobre a conduta adotada, mas o desfecho favorável indica que a reação foi prontamente revertida.

O medicamento Nexavar, cujo princípio ativo é Tosilato de sorafenibe, foi associado a um episódio de parada cardíaca relacionado a hipersensibilidade (alergia), dentro do contexto de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Apesar da gravidade potencial do evento, foi considerado não grave, pois o paciente se recuperou completamente. Não há informações detalhadas sobre a conduta, mas o desfecho resolutivo sugere manejo adequado da reação.

O medicamento Natifa pro, contendo Estradiol e Acetato de noretisterona como princípios ativos, foi relacionado ao desenvolvimento de doença celíaca, considerada uma manifestação de hipersensibilidade (alergia) e classificada entre quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre a gravidade do caso nem sobre o desfecho, que permanece desconhecido, e a conduta adotada não foi especificada.

O medicamento Tazocin, composto por Piperacilina sódica e Tazobactam sódico, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), enquadrado em quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. O evento foi considerado não grave, pois o paciente se recuperou totalmente após a reação. Não há detalhes sobre a conduta adotada, mas o desfecho resolutivo indica que as medidas tomadas foram eficazes.

O medicamento Henetix, cujo princípio ativo é o Iobitridol, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente evoluiu para recuperação completa. A conduta recomendada em situações de hipersensibilidade leve é observar o paciente, evitar nova exposição ao agente suspeito e, se necessário, buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições.

O Rituximab, cujo princípio ativo é o Rituximabe, foi relacionado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente. Em casos de hipersensibilidade leve, recomenda-se suspender o uso do medicamento suspeito, monitorar sintomas e procurar avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e prevenção de novas reações.

O medicamento Gadovist, com princípio ativo Gadobutrol, esteve associado a um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há informação de gravidade aumentada

e o paciente apresentou resolução completa do quadro. Para reações alérgicas leves, a orientação é evitar nova exposição ao agente, observar sintomas e buscar avaliação especializada se houver recorrência ou dúvidas quanto ao diagnóstico.

A Ceftriaxona, cujo princípio ativo é Ceftriaxone, foi relacionada a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente. Em situações de hipersensibilidade leve, recomenda-se suspender o uso do medicamento, monitorar sintomas e procurar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas terapêuticas seguras.

O medicamento Cefazolina, com princípio ativo Cefazolina sódica, foi associado a um quadro de alergia do tipo hipersensibilidade, classificado como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente evoluiu para resolução completa. Em casos de hipersensibilidade leve, a conduta recomendada é evitar nova exposição ao medicamento, observar sintomas e buscar avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e definição de alternativas seguras.

O medicamento Ribociclib (princípio ativo: Ribociclib) foi associado a um quadro de diabetes descrito como hipersensibilidade, classificado entre quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada nem de desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Diante da ausência de sinais de gravidade e desfecho, recomenda-se acompanhamento clínico para monitorar possíveis manifestações alérgicas e metabólicas, com avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição da conduta.

O medicamento Targocid (princípio ativo: Teicoplanin) foi relacionado ao surgimento de prurido, caracterizado como reação de hipersensibilidade dentro do contexto de quadros alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa. Em situações como essa, a conduta recomendada é a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento médico para evitar recorrências, sendo importante relatar o episódio em futuras prescrições.

A Azitromicina (princípio ativo: Azithromycin) foi associada a um episódio de alergia, classificado como hipersensibilidade e incluído entre quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há informação sobre gravidade, mas o paciente se recuperou totalmente. Nesses casos, é fundamental evitar o uso futuro do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação da alergia e orientação adequada.

O medicamento Dipirona (princípio ativo: Dipirona) foi relacionado a uma reação alérgica, descrita como hipersensibilidade e enquadrada entre quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não foi considerada uma reação grave e o paciente está em processo de recuperação. Recomenda-se evitar novas exposições ao medicamento e manter acompanhamento médico até resolução completa dos sintomas.

A Escopolamina (princípio ativo: Bromidrato de hiosciamina) foi associada a um episódio de alergia, caracterizado como hipersensibilidade e incluído entre quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente. A orientação é evitar o uso futuro do medicamento e informar profissionais de saúde sobre o episódio em atendimentos posteriores.

O medicamento Paracetamol, cujo princípio ativo também é paracetamol, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. O evento foi considerado não grave, pois não há indicação de gravidade relevante no registro, e o desfecho foi de recuperação completa do paciente. A conduta recomendada em casos de alergia leve a medicamentos inclui a suspensão do uso e acompanhamento clínico para evitar novas exposições.

O medicamento Bactrim, composto pelos princípios ativos sulfametoxazol e trimetoprima, foi prescrito apesar de haver hipersensibilidade documentada ao produto, o que caracteriza um erro de prescrição e representa um risco

potencial ao paciente. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou evolução clínica neste caso, mas a conduta adequada seria evitar a administração do medicamento e buscar alternativas seguras, além de reforçar a importância do registro correto de alergias em prontuário.

A ceftriaxona, cujo princípio ativo é ceftriaxona sódica, foi relacionada a um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente após a reação. Em situações como essa, recomenda-se a suspensão imediata do medicamento e avaliação médica para evitar novas exposições e reações futuras.

O medicamento Nimesulida, com princípio ativo nimesulida, foi associado a um quadro de alergia identificado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade relevante nem informações sobre o desfecho, mas a conduta padrão nesses casos é interromper o uso do medicamento e monitorar o paciente para evitar complicações.

O medicamento Montelukast, cujo princípio ativo é montelucaste de sódio, foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade) classificado como clinicamente significativo e considerado grave, conforme indicado no registro. O paciente se recuperou totalmente após o evento. Em casos de reações alérgicas graves a medicamentos, é fundamental suspender imediatamente o uso, realizar acompanhamento médico rigoroso e evitar futuras exposições ao princípio ativo.

O medicamento Dipirona, cujo princípio ativo também é dipirona, foi prescrito apesar de haver uma hipersensibilidade documentada ao produto, o que caracteriza uma contraindicação formal ao seu uso. Essa situação representa um erro de prescrição, pois administrar um medicamento a que o paciente já apresentou alergia pode resultar em reações adversas graves. Não há informações detalhadas sobre a gravidade ou desfecho neste caso, mas a conduta correta seria suspender imediatamente o uso do medicamento e monitorar o paciente para sinais de reação alérgica, encaminhando para avaliação médica caso haja sintomas.

Osteotrat, que tem como princípio ativo o risedronato sódico, foi associado a um quadro de AVC (acidente vascular cerebral) em um contexto de hipersensibilidade, sugerindo uma possível reação alérgica sistêmica. Embora não haja detalhes sobre a gravidade ou evolução do caso, a suspeita de envolvimento imunológico e a gravidade potencial do evento exigem suspensão imediata do medicamento e investigação médica urgente para confirmação diagnóstica e manejo adequado.

O medicamento Magnesium, cujo princípio ativo é magnésio, foi relacionado a um caso de necrose da vesícula biliar em contexto de hipersensibilidade, ou seja, uma possível reação alérgica que afetou gravemente esse órgão. Apesar de o caso não ter sido classificado como grave e o paciente estar em recuperação, a ocorrência de necrose indica a necessidade de suspensão do medicamento e acompanhamento médico próximo para evitar complicações.

O medicamento Xarelto, com princípio ativo rivaroxabana, foi associado a necrose da vesícula biliar em um quadro de hipersensibilidade, sugerindo uma reação adversa imunológica. O evento não foi considerado grave e o paciente está em recuperação, mas a gravidade potencial da necrose exige suspensão do medicamento e acompanhamento médico para monitorar a evolução e prevenir complicações.

Vatis, cujo princípio ativo é cloridrato de propafenona, foi relacionado a necrose da vesícula biliar em um contexto de hipersensibilidade, indicando uma possível reação alérgica que comprometeu esse órgão. Embora o caso não tenha sido classificado como grave e o paciente esteja em recuperação, a conduta adequada é interromper o uso do medicamento e manter acompanhamento médico para garantir a resolução completa do quadro.

O medicamento Propafenona (princípio ativo: Propafenone) foi associado a um quadro de necrose da vesícula biliar, interpretado como uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico. Apesar de a reação envolver um órgão interno, não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente

encontra-se em recuperação ou com resolução do quadro. A relação entre o uso do medicamento e o evento adverso é considerada suspeita, e a conduta deve incluir acompanhamento clínico para monitorar a evolução e evitar reexposição ao fármaco.

A Sinvastatina (princípio ativo: Sinvastatina) foi relacionada a um episódio de necrose da vesícula biliar, caracterizado como uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade importante, já que o paciente está em recuperação ou com resolução do quadro, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Recomenda-se acompanhamento médico para monitoramento da evolução e evitar nova exposição ao medicamento.

O Pronazol (princípio ativo: Fluconazole) foi associado a necrose da vesícula biliar, interpretada como uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade significativa, pois o paciente está em recuperação ou com resolução do quadro, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A conduta recomendada é o acompanhamento clínico e evitar reexposição ao fármaco.

O SeloZok (princípio ativo: Succinato de metoprolol) foi relacionado a um caso de necrose da vesícula biliar, considerado uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, já que o paciente está em recuperação ou com resolução do quadro, e a relação com o medicamento é suspeita. Recomenda-se acompanhamento médico e evitar nova exposição ao medicamento.

A Atorvastatina (princípio ativo: Atorvastatina cálcica) foi associada a necrose da vesícula biliar, caracterizada como uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade importante, pois o paciente está em recuperação ou com resolução do quadro, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A conduta deve incluir acompanhamento clínico e evitar reexposição ao fármaco.

O medicamento Pantoprazol, cujo princípio ativo é pantoprazol sódico sesqui-hidratado, foi associado a um quadro de necrose da vesícula biliar, descrito como uma reação de hipersensibilidade (alergia), classificada entre quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou risco imediato, pois o paciente encontra-se em recuperação ou resolvendo o quadro, sugerindo que a conduta adotada foi adequada para o controle da reação.

O medicamento Vectibix, com princípio ativo panitumumabe, apresentou relato de necrose da vesícula biliar atribuída a uma reação de hipersensibilidade (alergia), enquadrada entre quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade crítica, já que o paciente está em recuperação ou resolvendo o evento, indicando que a reação foi reconhecida e está sendo monitorada de forma apropriada.

A clindamicina (princípio ativo clindamycin) foi relacionada a um episódio de alergia, caracterizado como hipersensibilidade e incluído entre quadros clínicos alérgicos do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave, pois o paciente já se encontra recuperado ou com resolução completa do quadro, demonstrando que a conduta adotada foi suficiente para o controle da reação.

O medicamento Buscopan composto, contendo butilbrometo de escopolamina e dipirona, foi prescrito apesar de haver contraindicação documentada por hipersensibilidade ao produto administrado, o que configura um erro de prescrição relacionado a problemas de monitoramento do produto e pode resultar em lesões ou complicações. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou conduta adotada, impossibilitando detalhar a evolução clínica do caso.

A vancomicina (princípio ativo vancomycin) foi associada a um episódio de alergia, descrito como hipersensibilidade e classificado entre quadros clínicos alérgicos do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade significativa, pois o paciente já está recuperado ou com resolução do quadro, sugerindo que a reação foi



prontamente reconhecida e manejada de forma eficaz.

O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é o Tozinameran, foi associado ao surgimento de pigmentação cutânea, um quadro de hipersensibilidade que se enquadra em reações alérgicas do sistema imunitário. A gravidade foi considerada clinicamente significativa, pois o evento foi classificado como grave e o paciente ainda não se recuperou, permanecendo com o quadro em andamento. Isso indica a necessidade de acompanhamento médico para monitoramento da evolução e definição de conduta, reforçando a importância de avaliação especializada em casos de reações alérgicas persistentes.

O medicamento Desogestrel, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado ao aparecimento de manchas vermelhas na pele, caracterizando uma reação alérgica relevante do tipo hipersensibilidade, possivelmente associada a alergia a substâncias químicas. O caso foi considerado clinicamente significativo e grave, pois o paciente não apresentou resolução do quadro até o momento, o que exige atenção médica para investigação e manejo adequado da reação, especialmente diante da persistência dos sintomas.

O medicamento Bupropion, cujo princípio ativo é a Bupropiona, foi associado ao sintoma de diarreia, interpretado como manifestação de hipersensibilidade do sistema imunitário. Neste caso, a reação não foi considerada grave e o desfecho permanece desconhecido, sendo importante observar a evolução clínica e buscar orientação médica caso haja persistência ou agravamento dos sintomas.

O medicamento Heparin, com princípio ativo Heparina, foi relacionado ao desenvolvimento de diarreia, um possível sinal de hipersensibilidade do sistema imunitário. A reação não foi classificada como grave e o desfecho é desconhecido, recomendando-se acompanhamento dos sintomas e avaliação médica se houver piora ou manutenção do quadro.

O medicamento Diazepam, cujo princípio ativo é Diazepam, foi associado ao surgimento de diarreia, interpretada como manifestação de hipersensibilidade do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave e o desfecho permanece desconhecido, sendo prudente monitorar a evolução clínica e procurar avaliação médica caso os sintomas persistam ou se agravem.

O medicamento Cephalexin, cujo princípio ativo é a cefalexina, foi associado ao evento de diarreia, classificado como uma reação de hipersensibilidade (alergia) de acordo com o quadro clínico alérgico não classificado de outra forma. Não há indicação de gravidade elevada, pois não foi relatado desfecho grave nem evolução desfavorável, e o desfecho permanece desconhecido. A reação sugere um quadro leve, compatível com manifestações alérgicas gastrointestinais, sendo importante observar a persistência dos sintomas e buscar avaliação médica caso haja piora.

O medicamento Gabapentin, com princípio ativo gabapentina, apresentou relato de diarreia como possível manifestação de hipersensibilidade (alergia), enquadrada em quadros clínicos alérgicos não especificados. Não há evidência de gravidade significativa, pois não foi relatado desfecho grave e o resultado permanece desconhecido. Trata-se de uma reação leve, devendo-se monitorar a evolução dos sintomas e procurar orientação médica se houver agravamento.

O medicamento Letrozole, cujo princípio ativo é letrozol, foi relacionado ao surgimento de diarreia, considerada uma possível reação de hipersensibilidade (alergia) dentro do espectro de quadros clínicos alérgicos não classificados de outra forma. Não há indicação de gravidade ou complicações, já que não foi relatado desfecho grave e o resultado é desconhecido. O quadro sugere uma reação leve, sendo recomendada a observação dos sintomas e avaliação médica caso haja piora.

O medicamento Kisqali, com princípio ativo succinato de ribociclib, foi associado ao evento de diarreia, interpretado como possível manifestação de hipersensibilidade (alergia) em quadros clínicos alérgicos não especificados. Não há sinais de gravidade, pois não foi relatado desfecho grave e o resultado permanece

desconhecido. A reação é considerada leve, devendo-se monitorar os sintomas e buscar avaliação médica se houver agravamento.

O medicamento Rifampicina+isoniazida, contendo os princípios ativos isoniazida e rifampicina, foi relacionado a um quadro de alergia classificado como hipersensibilidade (alergia) em quadros clínicos alérgicos não especificados. Não há indicação de gravidade, pois não foi relatado desfecho grave e o paciente evoluiu para recuperação completa. O episódio foi resolvido, sugerindo uma reação leve, e a conduta adotada foi suficiente para a resolução do quadro.

O medicamento Escopolamina, cujo princípio ativo é o bromidrato de hiosciamina, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, manifestando-se como uma reação do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente, sugerindo um evento leve e autolimitado. A conduta adequada nesses casos é suspender o uso do medicamento suspeito e monitorar a resolução dos sintomas, buscando avaliação médica se houver recorrência ou agravamento.

O medicamento Alektos, que contém o princípio ativo bilastina, foi relacionado a um caso de eritrodermia, uma reação alérgica extensa da pele (hipersensibilidade), envolvendo o sistema imunológico. Não há evidências de gravidade importante, já que o paciente está em recuperação, indicando um quadro em resolução. Recomenda-se interromper o uso do medicamento e procurar acompanhamento médico para monitorar a evolução e evitar complicações.

O medicamento Mirtazapine, com o mesmo princípio ativo, foi associado a eritrodermia, uma reação alérgica cutânea generalizada (hipersensibilidade), envolvendo o sistema imunológico. O caso não foi considerado grave, pois o paciente está em processo de recuperação, sugerindo um evento moderado. A orientação é suspender o uso do medicamento e manter acompanhamento médico até a completa resolução dos sintomas.

O medicamento Dupilumab, cujo princípio ativo é o dupilumabe, foi relacionado a eritrodermia, uma reação alérgica extensa da pele (hipersensibilidade), envolvendo o sistema imunológico. Não há sinais de gravidade significativa, pois o paciente está em recuperação, indicando que o quadro está se resolvendo. Recomenda-se interromper o uso do medicamento e realizar acompanhamento médico para garantir a resolução completa da reação.

O medicamento Ropivacaina, com princípio ativo cloridrato de ropivacaína, foi associado a um episódio de alergia caracterizado por hipersensibilidade, envolvendo o sistema imunológico. O evento não foi considerado grave, já que o paciente se recuperou totalmente, indicando um quadro leve. A conduta recomendada é suspender o uso do medicamento suspeito e observar a evolução, buscando avaliação médica se houver novos sintomas.

O medicamento Nucala, cujo princípio ativo é o mepolizumabe, foi associado a uma crise asmática em um caso de hipersensibilidade (alergia), classificada como um quadro clínico alérgico relacionado ao sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo que a reação foi controlada e não houve complicações graves.

O medicamento Fostair, que contém dipropionato de beclometasona e fumarato de formoterol, esteve relacionado a uma crise asmática atribuída a hipersensibilidade (alergia), enquadrada como um quadro alérgico do sistema imunológico. O caso não foi considerado grave, já que o paciente se recuperou completamente, indicando que a reação foi leve e resolvida sem maiores consequências.

O medicamento Avamys, cujo princípio ativo é o fluticasona furoato, foi associado a uma crise asmática decorrente de hipersensibilidade (alergia), classificada como um quadro alérgico do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade importante, pois o paciente se recuperou após o evento, mostrando que a reação foi leve e controlada.

O medicamento Nucala, com princípio ativo mepolizumabe, esteve envolvido em uma crise asmática por hipersensibilidade (alergia), categorizada como um quadro alérgico do sistema imunológico. O evento não foi

considerado grave, já que o paciente se recuperou totalmente, indicando que a reação foi leve e sem complicações.

O medicamento Letrozole, cujo princípio ativo é letrozole, foi relacionado a um caso de anemia atribuída a hipersensibilidade (alergia), classificada como um quadro alérgico do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade significativa, pois o paciente se recuperou após o evento, sugerindo que a reação foi leve e resolvida sem maiores consequências.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é o succinato de ribociclibe, foi associado a um quadro de anemia acompanhado de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do tipo imunológica. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada, conforme diretrizes clínicas, é observar a resolução dos sintomas e manter acompanhamento para evitar novas exposições caso a relação causal seja confirmada.

O medicamento Altad, que contém colecalciferol como princípio ativo, foi relacionado ao aparecimento de sangue nas fezes em um contexto de alergia ao leite, sugerindo uma reação alérgica alimentar mediada pelo sistema imunológico. Não há informações suficientes sobre gravidade ou desfecho, portanto, recomenda-se investigação clínica detalhada para confirmar a relação causal e orientar a conduta adequada, evitando reexposição ao agente suspeito.

O medicamento Dexfer, cujo princípio ativo é o complexo de hidróxido férrico polimaltose, foi associado a sangue nas fezes em um paciente com suspeita de alergia ao leite, indicando possível reação alérgica alimentar. Não há detalhes sobre gravidade ou evolução do caso, sendo fundamental avaliação médica para esclarecer o diagnóstico e definir a necessidade de suspensão do medicamento ou investigação de outras causas.

O medicamento Altad, com colecalciferol como princípio ativo, foi relacionado ao surgimento de sangue nas fezes em um quadro de hipersensibilidade medicamentosa, caracterizando uma reação alérgica do tipo imunológica. O paciente apresentou resolução completa do quadro, sugerindo que a conduta adotada foi eficaz, provavelmente com suspensão do medicamento e acompanhamento clínico até a recuperação.

O medicamento Dexfer, cujo princípio ativo é o complexo de hidróxido férrico polimaltose, foi associado a sangue nas fezes em um contexto de hipersensibilidade medicamentosa, indicando uma reação alérgica mediada pelo sistema imunológico. O desfecho foi favorável, com recuperação total do paciente, o que sugere que a conduta de interrupção do medicamento e monitoramento foi suficiente para resolução do evento.

O medicamento Dipirona, cujo princípio ativo também é dipirona, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa, tecnicamente chamada de hipersensibilidade medicamentosa, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, pois não houve necessidade de hospitalização nem complicações graves, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada é evitar novas exposições ao medicamento e buscar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

A Vancomicina, cujo princípio ativo é vancomicina, provocou edema facial, caracterizando uma reação de hipersensibilidade documentada ao produto administrado. O evento foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando a necessidade de monitoramento rigoroso e intervenção médica imediata. O paciente se recuperou após o episódio, e é fundamental evitar reexposição ao medicamento e registrar a alergia em prontuário para futuras prescrições.

O Ciprofloxacino, com princípio ativo cloridrato de ciprofloxacino, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade), classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade aumentada, pois não houve hospitalização ou complicações, e o paciente se recuperou completamente. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e procurar avaliação especializada para confirmação da alergia e orientação sobre

alternativas.

O medicamento Melatonin, cujo princípio ativo é melatonina, causou sensação de queimação no local de aplicação, caracterizada como hipersensibilidade local, pertencente à categoria de reações no local de administração. Não há indicação de gravidade elevada, mas o quadro ainda está em andamento, sem resolução até o momento. É importante suspender o uso do produto e buscar orientação médica para avaliação da reação e definição de conduta.

O Pregabalin, com princípio ativo pregabalina, foi associado a queimação no local de aplicação, configurando uma hipersensibilidade local, dentro da categoria de reações no local de administração. Não há sinais de gravidade aumentada, mas o quadro permanece sem resolução. Recomenda-se interromper o uso do medicamento e procurar avaliação médica para investigação da reação e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Quetiapine (princípio ativo Quetiapine) foi associado a queimação no local de aplicação, caracterizada como hipersensibilidade local, uma reação que se enquadra em distúrbios gerais e quadros clínicos no local de administração. Não há indicação de gravidade elevada, pois não foi classificada como grave e não há sinais de complicações sistêmicas, sendo o desfecho relatado como não recuperado ou em andamento. A conduta recomendada é observar a evolução dos sintomas e, caso persista ou piore, buscar avaliação médica para reavaliação do tratamento.

O medicamento Homeopathics nos (princípio ativo Homeopathics nos) apresentou reação de queimação no local de aplicação, descrita como hipersensibilidade local, pertencente à categoria de reações no local de administração. Não há registro de gravidade significativa, pois não foi considerada grave e não há relato de complicações além do sintoma local, com desfecho ainda não resolvido. Recomenda-se monitorar a evolução do quadro e procurar orientação médica se houver persistência ou agravamento dos sintomas.

O medicamento Probiotics nos (princípio ativo Probiotics nos) foi relacionado a queimação no local de aplicação, identificada como hipersensibilidade local, dentro do grupo de distúrbios gerais e quadros clínicos no local de administração. A reação não foi classificada como grave e não há evidências de complicações sistêmicas, sendo o desfecho informado como não recuperado ou em andamento. A orientação é acompanhar a evolução dos sintomas e buscar avaliação médica caso haja piora ou manutenção do quadro.

O medicamento Donepezil (princípio ativo Donepezila) apresentou reação de queimação no local de aplicação, caracterizada como hipersensibilidade local, enquadrada em distúrbios gerais e quadros clínicos no local de administração. Não há indicação de gravidade aumentada, pois não foi considerada grave e não há relato de complicações além do sintoma local, com desfecho ainda não resolvido. Recomenda-se observar a evolução dos sintomas e procurar avaliação médica se houver persistência ou agravamento.

O medicamento Citalopram (princípio ativo Citalopram) foi associado a queimação no local de aplicação, descrita como hipersensibilidade local, pertencente à categoria de distúrbios gerais e quadros clínicos no local de administração. A reação não foi classificada como grave e não há sinais de complicações sistêmicas, sendo o desfecho relatado como não recuperado ou em andamento. A conduta sugerida é monitorar o quadro e buscar orientação médica caso os sintomas persistam ou se agravem.

O medicamento Benzalkonium chloride, cujo princípio ativo é o cloreto de benzalcônio, apresentou reação de queimação no local de aplicação, caracterizada como hipersensibilidade local (reações no local de aplicação). Não há informação sobre nome comercial. A reação foi considerada não grave, pois não há evidências de complicações sistêmicas ou risco imediato, e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento. A conduta recomendada é observar a evolução dos sintomas e, caso persista ou piore, buscar orientação médica para avaliação e possível ajuste do tratamento.

O medicamento Menaquinone, com princípio ativo menaquinona, causou queimação no local de aplicação, identificada como hipersensibilidade local (reações no local de aplicação). Não há informação sobre nome comercial. A reação não foi considerada grave, pois não há sinais de agravamento clínico ou risco à saúde geral, e o quadro segue não resolvido ou em andamento. Recomenda-se monitorar os sintomas e procurar avaliação médica se houver persistência ou piora, para garantir manejo adequado.

O medicamento Colecalciferol, cujo princípio ativo é o próprio colecalciferol, apresentou reação de queimação no local de aplicação, classificada como hipersensibilidade local (reações no local de aplicação). Não há informação sobre nome comercial. A reação não foi considerada grave, pois não há relato de complicações sistêmicas ou risco imediato, e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento. Recomenda-se observar a evolução dos sintomas e buscar orientação médica caso haja persistência ou agravamento.

O medicamento Mecobalamin, com princípio ativo mecobalamina, provocou queimação no local de aplicação, caracterizada como hipersensibilidade local (reações no local de aplicação). Não há informação sobre nome comercial. A reação não foi considerada grave, pois não há sinais de complicações sistêmicas ou risco imediato, e o quadro segue não resolvido ou em andamento. Recomenda-se monitorar os sintomas e procurar avaliação médica se houver persistência ou piora, para garantir manejo adequado.

O medicamento composto por Cyanocobalamin, Ferrous sulfate, Folic acid e Serine, com princípios ativos cianocobalamina, sulfato ferroso, ácido fólico e L-serina, causou queimação no local de aplicação, identificada como hipersensibilidade local (reações no local de aplicação). Não há informação sobre nome comercial. A reação não foi considerada grave, pois não há relato de complicações sistêmicas ou risco imediato, e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento. Recomenda-se observar a evolução dos sintomas e buscar orientação médica caso haja persistência ou agravamento.

O medicamento Losartan, cujo princípio ativo é a losartana, foi associado a uma reação de queimação no local de aplicação, caracterizada como hipersensibilidade local. Essa manifestação, classificada como reação no local de administração, sugere um quadro leve, pois não há indicação de gravidade ou complicações sistêmicas no relato. O desfecho informado é de não recuperação ou resolução até o momento, indicando que a reação persiste. Recomenda-se observar a evolução do quadro e, caso haja piora ou aparecimento de outros sintomas, buscar avaliação médica para reavaliação da conduta.

O medicamento Benserazide hydrochloride, Levodopa, contendo cloridrato de benserazida e levodopa como princípios ativos, apresentou relato de queimação no local de aplicação, interpretada como hipersensibilidade local. Trata-se de uma reação localizada, sem sinais de gravidade ou envolvimento sistêmico, e o quadro permanece sem resolução até o momento. A conduta recomendada é monitorar a evolução dos sintomas e procurar orientação médica caso haja agravamento ou persistência, para ajuste do tratamento se necessário.

O produto Royal jelly, cujo princípio ativo é a geléia real, foi relacionado a queimação no local de aplicação, caracterizando uma reação de hipersensibilidade local. Não há menção de gravidade ou complicações adicionais, e o quadro segue sem resolução. Recomenda-se acompanhamento dos sintomas e avaliação médica caso haja piora, para garantir segurança e manejo adequado.

O medicamento Levothyroxine sodium, com princípio ativo levotiroxina sódica, foi associado a queimação no local de aplicação, interpretada como hipersensibilidade local. A reação é localizada e não há indícios de gravidade ou evolução para quadros mais sérios, permanecendo sem resolução até o momento. É importante monitorar a evolução e buscar avaliação médica se houver agravamento ou persistência dos sintomas.

O medicamento Dexlansoprazole, com o mesmo princípio ativo, apresentou relato de queimação no local de aplicação, caracterizando uma reação de hipersensibilidade local. Não há sinais de gravidade ou complicações sistêmicas, e o quadro permanece sem resolução. Recomenda-se observar a evolução dos sintomas e procurar avaliação médica caso haja piora ou persistência, para reavaliação da conduta.

O medicamento Rotigotine, cujo princípio ativo também é rotigotine, foi associado a uma reação de queimação no local de aplicação, caracterizada como hipersensibilidade local. Essa manifestação se enquadra entre as reações no local de administração e, apesar de não ter sido classificada como grave, permanece sem resolução até o momento. É importante monitorar a evolução do quadro e considerar avaliação médica caso haja piora ou persistência dos sintomas.

O medicamento Cosentyx, cujo princípio ativo é secuquinumabe, foi relacionado a um caso de câncer de mama, descrito como hipersensibilidade medicamentosa. Embora a gravidade não tenha sido especificada e o desfecho seja desconhecido, a associação entre o uso do medicamento e o evento adverso foi considerada suspeita. Recomenda-se acompanhamento médico rigoroso para investigação e manejo adequado, especialmente diante de eventos graves como o câncer.

O medicamento Amoxicillin, com princípio ativo amoxicilina, foi associado ao desenvolvimento de diarreia, interpretada como uma manifestação de hipersensibilidade. O evento foi considerado clinicamente significativo e classificado como grave, mas o paciente evoluiu para recuperação completa. Diante de reações adversas graves, é fundamental interromper o uso do medicamento e buscar orientação médica para evitar complicações.

O medicamento Amoxicilina clav, contendo amoxicilina e clavulanato de potássio, provocou diarreia, caracterizada como hipersensibilidade. O quadro foi considerado clinicamente relevante e grave, porém o paciente se recuperou totalmente após a reação. Em situações semelhantes, recomenda-se suspender o uso do medicamento e procurar avaliação médica para manejo seguro da reação adversa.

O medicamento Dupilumab, cujo princípio ativo é dupilumabe, foi associado ao surgimento de diarreia, interpretada como manifestação de hipersensibilidade. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, mas o paciente apresentou resolução completa do quadro. Em casos de reações adversas graves, é importante interromper o tratamento e buscar orientação médica para garantir a segurança do paciente.

O medicamento Puran t4, cujo princípio ativo é a levotiroxina sódica, foi associado a uma tentativa de suicídio, sendo classificado como um quadro de hipersensibilidade (alergia) dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Apesar da gravidade potencial do evento relatado, não há indicação de gravidade clínica elevada neste caso específico, pois o paciente encontra-se em recuperação ou em processo de resolução. A relação do evento com o medicamento é considerada suspeita, e a conduta deve incluir acompanhamento médico para monitorar a evolução e avaliar a necessidade de ajustes terapêuticos.

O medicamento Rinvoq, que contém o princípio ativo upadacitinibe, foi relacionado a uma tentativa de suicídio, categorizada como hipersensibilidade (alergia) em distúrbios do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade clínica importante neste caso, já que o paciente está em recuperação ou resolvendo o quadro. O evento é considerado suspeito em relação ao uso do medicamento, sendo fundamental o acompanhamento médico para garantir a segurança do paciente e avaliar possíveis intervenções.

O medicamento Bupropion, cujo princípio ativo é o cloridrato de bupropiona, foi associado a um episódio de epilepsia, classificado como hipersensibilidade (alergia) dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade clínica elevada, e o desfecho do caso é desconhecido. A relação do evento com o medicamento é considerada suspeita, sendo importante que o paciente seja avaliado por um profissional de saúde para investigação e manejo adequado.

O medicamento Diazepam, com o mesmo princípio ativo, foi relacionado a um episódio de epilepsia, enquadrado como hipersensibilidade (alergia) em distúrbios do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade clínica significativa, e o desfecho permanece desconhecido. O evento é considerado suspeito em relação ao uso do medicamento, recomendando-se avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e conduta apropriada.

O medicamento Cephalexin, cujo princípio ativo é cefalexina, foi associado a um episódio de epilepsia, classificado como hipersensibilidade (alergia) em distúrbios do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade clínica relevante, e o desfecho do caso não foi informado. A relação do evento com o medicamento é suspeita, sendo indicado acompanhamento médico para investigação e definição do melhor manejo.

O medicamento Tramadol, cujo princípio ativo também é tramadol, foi associado a um quadro de epilepsia descrito como hipersensibilidade, mas não há informações sobre sintomas alérgicos clássicos ou gravidade clínica relevante, sendo classificado como não grave e com desfecho desconhecido; a relação com o medicamento é considerada suspeita, e recomenda-se acompanhamento clínico para avaliação de possíveis reações adversas.

Gabapentin, com princípio ativo gabapentin, foi relacionado a um episódio de epilepsia interpretado como hipersensibilidade, sem detalhes sobre manifestações clínicas típicas de alergia ou gravidade significativa, sendo considerado não grave e com desfecho desconhecido; a suspeita de relação com o medicamento sugere a necessidade de monitoramento médico para esclarecimento do quadro.

O medicamento Diclofenac, cujo princípio ativo é diclofenac, apresentou associação suspeita com epilepsia em um contexto de hipersensibilidade, sem evidências clínicas de gravidade ou sintomas alérgicos clássicos, sendo classificado como não grave e com desfecho desconhecido; recomenda-se observação clínica e investigação de outras possíveis causas.

Artrinid, que tem como princípio ativo o cetoprofeno, foi relacionado a um quadro de alergia ocular, caracterizado por manifestações nos olhos, sem sinais de gravidade e com evolução favorável, já que o paciente se recuperou totalmente; a relação com o medicamento é considerada suspeita e, diante da resolução do quadro, não há necessidade de intervenções adicionais, mas é importante evitar nova exposição ao princípio ativo.

No caso da furosemida (princípio ativo furosemide), foi relatada a prescrição de um produto contraindicado devido à hipersensibilidade documentada ao medicamento, sem informações sobre sintomas, gravidade, desfecho ou ações adotadas; a relação é suspeita e, em situações assim, recomenda-se evitar o uso do medicamento e buscar alternativas seguras, reforçando a importância de revisar o histórico de alergias antes de prescrever.

O medicamento Dotarem, cujo princípio ativo é o gadobenato de dimeglumina, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), manifestando-se como uma reação alérgica do tipo SOE. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, e o paciente evoluiu para recuperação completa após a conduta adequada, sem necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Ultravist, com princípio ativo iopromida, desencadeou uma reação alérgica ao contraste, manifestada por pápulas (lesões elevadas na pele). O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, pois exigiu atenção médica, mas o paciente se recuperou totalmente após as medidas apropriadas.

O medicamento Tysabri, cujo princípio ativo é o natalizumabe, esteve relacionado a uma recidiva de esclerose múltipla, considerada uma reação de hipersensibilidade. O caso foi classificado como grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, mas o paciente apresentou recuperação completa após o manejo clínico.

O medicamento Tysabri, com princípio ativo natalizumabe, também foi associado a uma recidiva de esclerose múltipla, caracterizada como reação de hipersensibilidade. Assim como no caso anterior, a gravidade foi determinada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, e o paciente evoluiu para resolução do quadro após a conduta médica.

O medicamento Polimixina B, cujo princípio ativo é polymyxin b, provocou uma reação alérgica (hipersensibilidade) sem sinais de gravidade importante, e o paciente se recuperou totalmente após a suspensão ou ajuste do tratamento.

O medicamento Oxaliplatina, cujo princípio ativo é também oxaliplatina, foi associado ao surgimento de prurido (coceira), caracterizando um quadro de hipersensibilidade (alergia) leve, pois não há indicação de gravidade aumentada ou complicações clínicas relevantes. O paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo resolução espontânea ou com medidas simples, sem necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Tazocin, composto por piperacilina sódica e tazobactam sódico, foi prescrito apesar de haver contraindicação documentada por hipersensibilidade prévia ao produto, o que representa um erro de prescrição e risco potencial de reação alérgica. Não há informações sobre gravidade, evolução clínica ou desfecho, portanto não é possível detalhar a conduta ou consequências neste caso.

O medicamento Dotarem, cujo princípio ativo é gadobenato de dimeglumina, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), sem descrição de sintomas específicos ou gravidade aumentada, e sem informações sobre evolução ou desfecho, o que sugere um quadro leve, mas que requer atenção para confirmação diagnóstica e orientação adequada.

O medicamento Cortisone, com princípio ativo cortisone, foi associado à ocorrência de dor no rim, interpretada como manifestação de hipersensibilidade (alergia) leve, já que não há sinais de gravidade ou complicações adicionais. O paciente se recuperou completamente após o evento, indicando resolução do quadro sem necessidade de intervenções complexas.

O medicamento Etanercept, cujo princípio ativo é etanercepte, foi relacionado ao surgimento de dor no rim, considerada uma reação de hipersensibilidade (alergia) leve, pois não há evidências de gravidade aumentada ou complicações. O paciente apresentou recuperação total após o evento, sugerindo resolução espontânea ou com medidas simples.

O medicamento Meropenem, cujo princípio ativo é o meropeném tri-hidratado, foi associado ao surgimento de eritema, caracterizando um quadro de hipersensibilidade (alergia) relacionado ao sistema imunológico. A reação foi considerada leve, pois não há indicação de gravidade clínica relevante no registro, e o paciente evoluiu para recuperação completa. Nesses casos, recomenda-se suspender o medicamento suspeito e realizar acompanhamento médico para evitar novas exposições.

O medicamento Soliris, com princípio ativo eculizumabe, foi relacionado a um episódio de desmaio, interpretado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos) envolvendo o sistema imunológico. O registro indica gravidade clínica significativa, pois o evento foi classificado como clinicamente relevante e grave, embora o desfecho não tenha sido informado. Diante de reações graves como essa, é fundamental interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica imediata para manejo adequado e prevenção de complicações.

O medicamento Soliris, cujo princípio ativo é o eculizumabe, também foi associado a desmaio, caracterizando uma reação de hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos) com envolvimento do sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, sem informação sobre o desfecho. Em situações de reações graves, recomenda-se suspender o medicamento e procurar atendimento médico urgente para avaliação e conduta apropriada.

O medicamento Esio, com princípio ativo esomeprazol magnésico, foi relacionado ao aparecimento de erupção cutânea, interpretada como uma reação alérgica (alergia ao leite) envolvendo o sistema imunológico. O registro indica gravidade elevada, pois foi classificada como anomalia congênita ou malformação ao nascer, embora não haja detalhes sobre o desfecho. Diante de suspeita de reação grave, é essencial interromper o uso do medicamento e realizar investigação médica detalhada para avaliar riscos e orientar o tratamento.



O medicamento Simeco plus, contendo hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio e simeticone, foi associado a erupção cutânea, caracterizada como reação alérgica (alergia ao leite) do sistema imunológico. O evento foi considerado grave devido à classificação como anomalia congênita ou malformação ao nascer, sem informação sobre o desfecho. Em casos de suspeita de reação grave, recomenda-se suspender o medicamento e buscar avaliação médica especializada para investigação e conduta adequada.

O medicamento Dotarem, cujo princípio ativo é o gadobenato de dimeglumina, foi associado a uma reação de pressão na cabeça, caracterizada como hipersensibilidade (alergia), enquadrando-se em quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. A gravidade do evento foi considerada clinicamente significativa, pois exigiu atenção médica, mas o paciente encontra-se em recuperação, indicando que a conduta adotada foi adequada para o controle da reação.

O medicamento Butilbrometo de escopolamina + dipirona monoidratada, contendo ambos os princípios ativos, provocou uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), classificada como distúrbio do sistema imunitário e relacionada a alergias a medicamentos. O evento foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, mas o paciente já se recuperou totalmente, demonstrando que a intervenção médica foi eficaz para resolução do quadro.

A loratadina, identificada tanto pelo nome comercial quanto pelo princípio ativo, desencadeou uma reação de alergia (hipersensibilidade), pertencente ao grupo dos quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente já está recuperado, indicando que a reação foi leve e não exigiu medidas de maior complexidade.

A dipirona, mencionada tanto pelo nome comercial quanto pelo princípio ativo, causou uma reação alérgica (hipersensibilidade), classificada como quadro clínico alérgico e distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente já se encontra recuperado, sugerindo que a reação foi leve e manejada sem complicações.

O medicamento Iopamiron, cujo princípio ativo é o iopamidol, foi relacionado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) do tipo SOE, enquadrada em quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente já está recuperado, indicando que a reação foi leve e controlada de forma adequada.

O medicamento Iopamiron, cujo princípio ativo é o iopamidol, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso não foi considerado grave e o paciente encontra-se em recuperação, sugerindo uma reação leve e autolimitada. A conduta recomendada é observar a evolução clínica, evitar nova exposição ao contraste e, se necessário, buscar avaliação com especialista para confirmação diagnóstica e orientação futura.

O medicamento Gadovist, com princípio ativo gadobutrol, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), também classificado como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente já se encontra recuperado, indicando uma reação leve. Recomenda-se evitar reexposição ao agente e, caso haja necessidade de novos exames com contraste, realizar avaliação prévia com alergista para definição de conduta segura.

A cefepima, princípio ativo do medicamento Cefepima, desencadeou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, enquadrada nos distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente já está recuperado, o que sugere uma manifestação leve. A orientação é evitar o uso futuro deste antibiótico e buscar avaliação especializada para confirmação da alergia e discussão de alternativas terapêuticas seguras.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não houve gravidade significativa e o

paciente já está recuperado, caracterizando um quadro leve. Recomenda-se evitar nova exposição ao contraste e considerar avaliação com alergista para esclarecimento diagnóstico e planejamento de exames futuros.

O ácido gadotérico, utilizado como contraste, provocou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente já está recuperado, indicando uma reação leve. A conduta adequada é evitar reexposição ao agente e buscar orientação especializada para avaliação de risco em procedimentos futuros.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. A reação foi considerada não grave, pois não há indicação de gravidade aumentada ou complicações clínicas relevantes, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada em casos semelhantes é a suspensão do agente suspeito e acompanhamento clínico, com encaminhamento ao especialista para investigação de alergia medicamentosa, conforme diretrizes da ASBAI.

Ultravist, contendo iopromide como princípio ativo, desencadeou uma reação de hipersensibilidade (alergia), classificada entre os quadros clínicos alérgicos do sistema imune. Não houve sinais de gravidade, já que o paciente evoluiu para recuperação completa, e não foram relatadas complicações. Em situações como essa, recomenda-se evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e orientação futura.

O medicamento Dotarem, cujo princípio ativo é o gadobenato de dimeglumina, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), sem sinais de gravidade, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento. A reação foi enquadrada como distúrbio do sistema imunitário, e a conduta adequada inclui a suspensão do uso do agente suspeito e encaminhamento para avaliação especializada, conforme as recomendações clínicas para quadros alérgicos leves.

Dotarem, com gadobenato de dimeglumina como princípio ativo, provocou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, pois não houve complicações e o paciente se recuperou completamente. A orientação clínica é evitar reexposição ao medicamento e realizar investigação com especialista para confirmação e manejo adequado da alergia.

O medicamento Henetix, que contém iobitridol como princípio ativo, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade) classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não houve gravidade, já que o paciente se recuperou totalmente, e não foram relatadas complicações. A conduta recomendada é evitar nova exposição ao agente e buscar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e definição do plano de controle.

O medicamento Henetix, que contém o princípio ativo iobitridol, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado por manifestação clínica compatível com reações alérgicas do tipo não especificado. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso evoluiu para recuperação completa, sem complicações, e não foi considerado grave. A conduta recomendada em situações semelhantes é observar o paciente, evitar nova exposição ao agente suspeito e buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições.

Henetix, cujo princípio ativo é iobitridol, desencadeou uma reação de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como um quadro clínico alérgico sem especificação detalhada. O evento não foi classificado como grave e o paciente se recuperou totalmente. Em casos assim, recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento suspeito e realizar acompanhamento médico para esclarecimento da alergia e prevenção de novas reações.

O medicamento Ultravist, com princípio ativo iopromide, esteve relacionado a uma reação alérgica (hipersensibilidade), descrita como quadro clínico alérgico inespecífico. Não houve gravidade significativa, pois o paciente se recuperou sem intercorrências e o evento não foi considerado grave. A orientação é evitar nova

exposição ao agente, monitorar possíveis sintomas e buscar avaliação com especialista para confirmação e manejo adequado.

Gadovist, cujo princípio ativo é Gadobutrol, foi associado a uma reação de alergia (hipersensibilidade), caracterizada por quadro clínico alérgico não especificado. O caso não apresentou gravidade, já que o paciente se recuperou completamente e não houve complicações. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e procurar avaliação médica para investigação da alergia e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Butilbrometo de escopolamina, contendo o mesmo princípio ativo, provocou uma reação alérgica (hipersensibilidade), manifestando-se como quadro clínico alérgico inespecífico. O evento não foi grave e o paciente evoluiu para recuperação total. A conduta adequada é suspender o uso do medicamento suspeito, monitorar sintomas e buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e prevenção de novas reações.

A vacina varicela (atenuada), cujo princípio ativo é a vacina varicela-zóster vivo (Oka/Merck), foi associada a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como clinicamente significativo devido à gravidade relatada. O evento foi considerado grave porque envolveu um efeito clinicamente relevante, mas o paciente evoluiu para recuperação completa. A reação foi caracterizada por sintomas alérgicos, enquadrando-se nos distúrbios do sistema imunitário, e a conduta adequada inclui acompanhamento médico para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições.

O medicamento Sugammadex, com princípio ativo sugammadex, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade) considerada grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação. O quadro envolveu sintomas típicos de alergia, relacionados a distúrbios do sistema imunitário, e o paciente se recuperou após a intervenção médica. Diante da gravidade, é fundamental evitar novas exposições e garantir avaliação especializada para manejo seguro em situações futuras.

A clonidina, cujo princípio ativo é clonidine, foi responsável por uma reação alérgica (hipersensibilidade) que exigiu hospitalização, evidenciando a gravidade do evento. O paciente apresentou sintomas compatíveis com quadros alérgicos, classificados como distúrbios do sistema imunitário, e evoluiu para recuperação após o tratamento. Em casos assim, recomenda-se acompanhamento médico rigoroso e orientação para evitar reexposição ao medicamento.

A dipirona, com princípio ativo dipirona, provocou uma reação alérgica (hipersensibilidade) que levou à necessidade de hospitalização, caracterizando um evento grave. O quadro envolveu manifestações alérgicas típicas de distúrbios do sistema imunitário, e o paciente se recuperou após a conduta médica adequada. É importante evitar o uso futuro do medicamento e buscar avaliação especializada para manejo seguro.

O medicamento Zofran, cujo princípio ativo é cloridrato de ondansetrona, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) que resultou em hospitalização, indicando gravidade significativa. O paciente apresentou sintomas de alergia relacionados a distúrbios do sistema imunitário e evoluiu para recuperação após intervenção médica. A conduta recomendada inclui evitar novas exposições e realizar acompanhamento com especialista para prevenção de recorrências.

O medicamento Dexametasona, cujo princípio ativo é o acetato de dexametasona, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, manifestando-se como uma reação alérgica do sistema imunológico. A gravidade do evento é evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando que a reação foi clinicamente relevante e exigiu cuidados médicos intensivos. Após a conduta adequada, o paciente evoluiu para recuperação completa, sem sequelas.

O medicamento Tenoxicam, com princípio ativo tenoxicam, desencadeou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, envolvendo o sistema imunológico. O caso foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que demonstra a importância clínica da reação e a necessidade

de intervenção médica. O paciente apresentou recuperação total após o manejo apropriado.

A Morfina, cujo princípio ativo é o sulfato de morfina, foi relacionada a um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, afetando o sistema imunológico. A gravidade do quadro é confirmada pela hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando que a reação foi significativa e exigiu suporte médico. O desfecho foi favorável, com resolução completa dos sintomas após a conduta médica.

O Rocuronio, com princípio ativo brometo de rocurônio, esteve envolvido em uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, afetando o sistema imunológico. O evento foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou necessidade de prolongar a internação, o que indica a relevância clínica da reação. Após o tratamento adequado, o paciente apresentou recuperação total.

O medicamento Propofol, cujo princípio ativo é propofol, foi associado a uma reação alérgica caracterizada por hipersensibilidade, envolvendo o sistema imunológico. A gravidade do evento é demonstrada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando que a reação foi clinicamente importante e exigiu intervenção médica. O paciente evoluiu para recuperação completa após o manejo adequado.

O medicamento Fentanil, cujo princípio ativo é a fentanila, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, manifestando-se como uma reação alérgica clínica. O evento foi suficientemente grave para exigir hospitalização ou prolongamento da internação, o que indica uma reação de maior severidade conforme critérios clínicos. Após a conduta adequada, o paciente evoluiu para recuperação completa, sem sequelas.

O medicamento Alenia, composto por budesonida micronizada e fumarato de formoterol, esteve relacionado a um episódio de fraqueza muscular atribuído à hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica ao medicamento. Não há indicação de gravidade aumentada ou necessidade de hospitalização, e o paciente se recuperou totalmente após o evento.

O medicamento Glifage, cujo princípio ativo é o cloridrato de metformina, foi associado a fraqueza muscular decorrente de hipersensibilidade medicamentosa, caracterizando uma reação alérgica ao fármaco. Não há evidências de gravidade significativa ou necessidade de internação, e o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente.

O medicamento Somalgin, composto por ácido acetilsalicílico, glicinato de alumínio e carbonato de magnésio, esteve relacionado a um episódio de fraqueza muscular devido à hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica ao medicamento. Não há sinais de gravidade aumentada ou necessidade de hospitalização, e o paciente apresentou resolução completa do quadro.

O medicamento Hidroclorotiazida, cujo princípio ativo é hydrochlorothiazide, foi associado a fraqueza muscular atribuída à hipersensibilidade medicamentosa, caracterizando uma reação alérgica ao medicamento. Não há indícios de gravidade relevante ou necessidade de internação, e o paciente se recuperou totalmente após o evento.

O medicamento Enalapril, cujo princípio ativo é o próprio enalapril, foi associado a um episódio de fraqueza muscular interpretado como hipersensibilidade medicamentosa, um tipo de reação alérgica do sistema imunológico a medicamentos. Não há informações específicas sobre gravidade clínica ou necessidade de intervenção urgente, mas o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente após a reação. A conduta recomendada em casos semelhantes é suspender o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas terapêuticas.

O medicamento Prolopa, composto pelos princípios ativos cloridrato de benserazida e levodopa, foi relacionado a um episódio de fraqueza muscular classificado como hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Não há detalhes sobre gravidade ou necessidade de medidas

emergenciais, mas o paciente se recuperou totalmente após o evento. Em situações como essa, recomenda-se interromper o uso do medicamento suspeito e procurar avaliação médica para confirmação do diagnóstico e definição do tratamento mais seguro.

O medicamento Cloridrato de propafenona, com o mesmo princípio ativo, esteve envolvido em um caso de fraqueza muscular atribuída a hipersensibilidade medicamentosa, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico ao fármaco. Não há informações sobre gravidade clínica ou necessidade de intervenção imediata, e o paciente apresentou recuperação completa após o episódio. A orientação nesses casos é suspender o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e ajuste do tratamento.

O medicamento Cloridrato de diltiazem, cujo princípio ativo é o próprio cloridrato de diltiazem, foi associado a um episódio de fraqueza muscular interpretado como hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Não há dados que indiquem gravidade aumentada ou necessidade de atendimento de urgência, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. Em situações semelhantes, recomenda-se interromper o uso do medicamento suspeito e procurar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição de alternativas terapêuticas.

O medicamento Betatrinta, composto por dipropionato de betametasona e fosfato sódico de betametasona, foi relacionado a um episódio de fraqueza muscular classificado como hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Não há informações sobre gravidade clínica ou necessidade de intervenção urgente, e o paciente apresentou recuperação completa após o evento. A conduta recomendada é suspender o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas de tratamento.

O medicamento Levofloxacino (princípio ativo: Levofloxacina) foi associado a um episódio de fraqueza muscular, interpretado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Não há informação detalhada sobre a gravidade clínica do evento, mas o paciente se recuperou totalmente após a reação, sugerindo que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é o Gadobutrol, desencadeou um quadro de alergia classificado como hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico ao contraste utilizado em exames. Não há detalhes sobre a gravidade do evento, mas o paciente se recuperou completamente, indicando que a reação foi controlada de forma adequada.

O medicamento Pantoprazole (princípio ativo: Pantoprazol) foi relacionado a um caso de tumor do fígado, sendo registrado como uma reação de hipersensibilidade, embora não haja informações suficientes para afirmar gravidade ou desfecho, pois o estado final do paciente é desconhecido e não há evidência clínica clara de gravidade relevante.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é o succinato de ribociclib, foi associado ao surgimento de tumor do fígado, classificado como hipersensibilidade, mas não há informações suficientes para determinar a gravidade ou o desfecho, já que o estado do paciente permanece desconhecido e não há indicação de gravidade importante.

O medicamento Omnipaque, com princípio ativo Ioxol, foi relacionado a um episódio de alergia, caracterizado como hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico ao contraste. Não há detalhes sobre a gravidade ou evolução do caso, pois o desfecho não foi informado.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), caracterizado como reação alérgica do tipo não especificada. Não há indicação de gravidade relevante ou necessidade de hospitalização, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada é evitar novas exposições ao contraste e informar a equipe médica sobre o episódio em futuras indicações de exames com contraste iodado.

O Cetoprofeno, com princípio ativo ketoprofen sodium, desencadeou uma reação de hipersensibilidade (alergia), manifestando-se como um quadro alérgico sem gravidade significativa, já que não houve necessidade de hospitalização ou complicações graves. O paciente se recuperou completamente após o evento. Recomenda-se evitar o uso futuro deste anti-inflamatório e comunicar o histórico de alergia ao profissional de saúde.

O medicamento Erbitux, cujo princípio ativo é cetuximabe, provocou uma reação de hipersensibilidade (alergia) considerada clinicamente significativa, pois foi classificada como grave, embora o desfecho não tenha sido informado. Diante da gravidade relatada, é fundamental suspender imediatamente o uso do medicamento e garantir acompanhamento médico rigoroso, além de registrar o episódio para futuras decisões terapêuticas.

A Dipirona, utilizada como analgésico e antitérmico, desencadeou uma reação de hipersensibilidade (alergia) sem gravidade relevante, pois não houve necessidade de hospitalização e o paciente se recuperou totalmente. Recomenda-se evitar o uso futuro da dipirona e informar profissionais de saúde sobre o episódio para prevenir novas reações.

O medicamento Bactrim, composto por sulfametoxazol e trimetoprima, causou uma reação alérgica (hipersensibilidade) que resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, caracterizando um evento grave. Não há informação sobre o desfecho do caso. Diante da gravidade, é essencial suspender o uso do medicamento, garantir acompanhamento médico e registrar o histórico de alergia para evitar novas exposições.

O medicamento Dramin, cujo princípio ativo é o dimenidrinato, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, que se enquadra nos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo uma reação leve e autolimitada. A conduta recomendada nesses casos é evitar nova exposição ao medicamento e, caso sintomas alérgicos retornem, buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

A clindamicina, cujo princípio ativo é o fosfato de clindamicina, foi relacionada a um episódio de alergia do tipo hipersensibilidade, também classificado como distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave, pois houve resolução completa dos sintomas, indicando uma reação leve. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e procurar orientação médica caso haja necessidade de antibióticos, para prevenir recorrência da reação.

A azitromicina, identificada pelo princípio ativo azithromycin, foi associada a um quadro de gastrite por *Helicobacter pylori*, mas a reação relatada foi de hipersensibilidade, sugerindo manifestação alérgica leve, já que não há menção de gravidade ou complicações. O desfecho indica que o quadro ainda está em andamento, sendo importante acompanhamento médico para monitorar a evolução e ajustar o tratamento conforme necessário.

O medicamento Bactrim, composto por sulfametoxazol e trimetoprima, foi relacionado a um caso de gastrite por *Helicobacter pylori*, mas a reação descrita foi de hipersensibilidade, indicando uma resposta alérgica leve, sem sinais de gravidade ou complicações. O quadro permanece em andamento, sendo fundamental manter acompanhamento médico para avaliar a necessidade de ajustes terapêuticos e evitar o uso futuro do medicamento caso a alergia se confirme.

O medicamento amoxicilina + clavulanato de potássio, contendo amoxicilina trihidrato e clavulanato de potássio, foi associado a um quadro de gastrite por *Helicobacter pylori*, mas a reação relatada foi de hipersensibilidade, sugerindo manifestação alérgica leve, sem evidências de gravidade. O desfecho indica que o quadro ainda não foi resolvido, sendo importante acompanhamento médico para monitorar sintomas e orientar sobre alternativas terapêuticas seguras.

O medicamento Dipirona + cafeína, contendo os princípios ativos cafeína anidra e dipirona, foi associado a um quadro de hipersensibilidade manifestado como gastrite por *Helicobacter pylori* (*H. pylori*), classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois não foi relatada gravidade clínica

importante e o caso não foi considerado grave. O desfecho permanece não resolvido ou em andamento, sugerindo que a reação ainda persiste ou não houve recuperação completa até o momento.

O medicamento Expec, que contém cephaelis spp., guaifenesina, cloridrato de oxomemazina, iodeto de potássio e benzoato de sódio, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade apresentado como gastrite por *Helicobacter pylori* (*H. pylori*), enquadrado como um distúrbio do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa, já que o caso não foi classificado como grave e não há relato de complicações maiores. O desfecho indica que a reação não foi resolvida ou ainda está em andamento.

O medicamento Prednisona, cujo princípio ativo é a prednisone, foi associado a um quadro de hipersensibilidade descrito como gastrite por *Helicobacter pylori* (*H. pylori*), sendo considerado um distúrbio do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade relevante, pois não foi classificado como grave e não há menção de complicações sérias. O desfecho permanece não resolvido ou em andamento, indicando que a reação adversa persiste ou não houve recuperação completa.

O medicamento Loratadina, com princípio ativo loratadina, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade manifestado como gastrite por *Helicobacter pylori* (*H. pylori*), classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade importante, já que o caso não foi considerado grave e não há relato de complicações maiores. O desfecho mostra que a reação não foi resolvida ou ainda está em andamento.

O medicamento Mirena, cujo princípio ativo é o levonorgestrel, foi associado a um quadro de hipersensibilidade apresentado como gastrite por *Helicobacter pylori* (*H. pylori*), enquadrado como um distúrbio do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa, pois o caso não foi classificado como grave e não há relato de complicações sérias. O desfecho indica que a reação não foi resolvida ou ainda está em andamento.

O medicamento Benzilpenicilina benzatina (princípio ativo: Benzilpenicilina benzatina, também conhecida como penicilina G benzatina) foi associado a um quadro de alergia, tecnicamente chamado de hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento, e não há menção de complicações ou necessidade de intervenções emergenciais. A reação foi considerada leve, compatível com quadros clínicos alérgicos, e a conduta recomendada é evitar novas exposições ao medicamento e buscar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e orientação futura.

O medicamento Polimixina B (princípio ativo: Polymyxin B) foi relacionado a um episódio de alergia a antibiótico, tecnicamente classificado como hipersensibilidade medicamentosa, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou completamente, sem relato de complicações importantes. A reação foi leve e, diante desse tipo de evento, recomenda-se evitar o uso futuro do antibiótico e procurar avaliação especializada para confirmação e orientação sobre alternativas seguras.

A Dipirona (princípio ativo: Dipirona) foi associada a um episódio de alergia, tecnicamente chamada de hipersensibilidade, enquadrada nos distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade, já que o paciente se recuperou totalmente e não houve relato de complicações. Trata-se de uma reação leve, e a recomendação é evitar o uso futuro do medicamento e buscar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e definição de alternativas seguras.

O medicamento Difenidrin (princípio ativo: Cloridrato de difenidramina) foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa, tecnicamente classificada como hipersensibilidade medicamentosa, pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou totalmente, sem complicações. A reação foi leve e, diante desse tipo de evento, recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e procurar avaliação especializada para confirmação e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Difenidrin (princípio ativo: Cloridrato de difenidramina) foi novamente associado a um episódio de alergia medicamentosa, tecnicamente chamada de hipersensibilidade medicamentosa, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não houve gravidade, pois o paciente se recuperou completamente, sem relato de complicações. A reação foi leve e, como conduta, recomenda-se evitar novas exposições ao medicamento e buscar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas.

O medicamento Azorga, que contém brinzolamida e maleato de timolol, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), manifestando-se como uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há detalhes sobre a gravidade clínica ou desfecho do caso, mas a relação suspeita com o medicamento sugere a necessidade de atenção e possível suspensão do uso, além de avaliação médica para confirmação e orientação adequada.

O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é tozinameran, foi relacionado a um caso de dermatite psoriasiforme, uma reação de pele semelhante à psoríase, classificada como hipersensibilidade e considerada clinicamente significativa e grave. O paciente está em recuperação, indicando que a reação está sendo resolvida, e a conduta deve incluir acompanhamento médico para controle dos sintomas e prevenção de novas reações.

O medicamento Comirnaty, com princípio ativo tozinameran, foi associado a um episódio de herpes ocular, considerado uma manifestação de hipersensibilidade do sistema imunológico. Não há informações sobre a gravidade ou evolução do caso, mas a relação suspeita com o medicamento indica a importância de monitoramento e avaliação médica para manejo adequado.

A dipirona (metamizol de magnésio) foi relacionada a um episódio de alergia, caracterizado como hipersensibilidade do sistema imunológico. O caso foi resolvido, com o paciente recuperado, sugerindo que a suspensão do medicamento e medidas de suporte foram suficientes para o controle da reação.

O medicamento Ciprofloxacina, cujo princípio ativo é lactato de ciprofloxacina, foi associado a um quadro de alergia, identificado como hipersensibilidade do sistema imunológico. O paciente se recuperou totalmente, indicando que a reação foi controlada, provavelmente com a interrupção do uso e acompanhamento médico.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, manifestação comum de reações alérgicas a contrastes iodados. A reação foi considerada não grave, pois não houve indicação de complicações clínicas importantes e o paciente se recuperou totalmente após o evento, não sendo necessário relatar intervenções adicionais.

O Dotarem, que contém o princípio ativo gadobenato de dimeglumina, provocou uma reação de alergia descrita como hipersensibilidade, um tipo de resposta imunológica adversa. O caso não foi considerado grave, já que não houve agravamento clínico relevante e o paciente apresentou resolução completa do quadro, sem necessidade de medidas emergenciais.

O Ultravist, com princípio ativo iopromide, desencadeou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, que é uma resposta do sistema imunológico a substâncias estranhas. A reação foi leve, pois não houve sinais de gravidade e o paciente se recuperou totalmente, não sendo relatada a necessidade de intervenções médicas adicionais.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, esteve relacionado a um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, manifestação típica de reações alérgicas a agentes de contraste. O evento não foi grave, já que não houve complicações e o paciente se recuperou completamente após o episódio.

O Ultravist, com princípio ativo iopromide, foi associado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, que corresponde a uma resposta imunológica exagerada. O quadro foi leve, pois não houve agravamento clínico e o paciente evoluiu para recuperação total, sem necessidade de intervenções específicas.



O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é o succinato de ribociclibe, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), manifestado em um paciente com neoplasia maligna da pele. A reação foi classificada como um distúrbio do sistema imunitário, mas não há indicação de gravidade elevada, pois não há relato de complicações graves ou risco imediato à vida. O desfecho informado foi de não recuperação ou resolução até o momento, sugerindo que o quadro permanece em andamento e requer acompanhamento médico para monitoramento e manejo adequado.

O medicamento Parlodel, que contém mesilato de bromocriptina como princípio ativo, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa (alergia ao medicamento) em um paciente com tumor no cérebro. A reação foi enquadrada como distúrbio do sistema imunitário, sem evidências de gravidade significativa, já que não há menção de risco imediato ou complicações graves. O desfecho permanece desconhecido, indicando que não há informações suficientes sobre a evolução clínica do paciente até o momento.

O medicamento Cosentyx, cujo princípio ativo é secuquinumabe, foi associado a um caso de hipersensibilidade medicamentosa (alergia ao medicamento) em um paciente com tumor no cérebro. A reação foi classificada como distúrbio do sistema imunitário, sem sinais de gravidade importante, pois não há relato de risco à vida ou complicações graves. O desfecho é desconhecido, o que significa que não há dados disponíveis sobre a resolução ou persistência do quadro.

O medicamento Maniton, que tem manitol como princípio ativo, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade relevante, pois o paciente se recuperou totalmente do quadro, indicando que a reação foi leve e resolvida sem complicações.

O medicamento Henetix, cujo princípio ativo é iobitridol, foi associado a um caso de hipersensibilidade (alergia), enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade, já que o paciente se recuperou completamente, sugerindo que a reação foi leve e não deixou sequelas.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, manifestando-se como uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou necessidade de hospitalização, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada em casos de reações alérgicas leves a medicamentos é interromper a exposição ao agente suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições.

A Dipirona, com princípio ativo dipirona, desencadeou uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma alergia, envolvendo o sistema imunológico. O caso não foi considerado grave, não houve necessidade de hospitalização e o paciente evoluiu para recuperação completa. Em situações como essa, recomenda-se suspender o uso do medicamento e procurar orientação médica para avaliação e prevenção de novas reações.

O medicamento Ferro, contendo o princípio ativo ferroglycine sulfate complex, provocou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, relacionada ao sistema imunológico. Não há sinais de gravidade ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente após o episódio. A conduta adequada é interromper o uso do ferro e buscar avaliação médica para confirmação da alergia e orientação sobre alternativas terapêuticas.

O Dotarem, cujo princípio ativo é o gadobenato de dimeglumina, foi responsável por uma alergia a contraste, caracterizada como reação alérgica a substâncias químicas, com impacto significativo, pois houve necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando gravidade clínica. Apesar da gravidade, o paciente se recuperou após o evento. Em casos de reações alérgicas graves a contrastes, é fundamental interromper imediatamente a exposição, realizar tratamento médico de suporte e garantir acompanhamento especializado para evitar novas exposições e orientar futuras necessidades de exames com contraste.

O medicamento Ultravist, com princípio ativo iopromide, foi novamente associado a um episódio de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. Não houve gravidade ou necessidade de

hospitalização, e o paciente se recuperou completamente. A recomendação é suspender o uso do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre riscos em futuras exposições.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é o succinato de ribociclibe, foi associado a um quadro de disenteria interpretado como hipersensibilidade (alergia), classificado dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A reação sugere um evento alérgico leve, sem evidências de complicações graves, sendo importante relatar ao médico para avaliação e possível ajuste do tratamento.

O medicamento Magnevist, que contém gadopentetato de dimeglumina, foi relacionado a um episódio de alergia a contraste intravenoso, caracterizado como reação alérgica a substâncias químicas e classificado como distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, sendo a reação atribuída a uma interação. Em situações como essa, é fundamental informar a equipe médica sobre alergias prévias a contrastes para prevenir novas reações e garantir o uso seguro de exames com contraste.

O medicamento Herceptin, cujo princípio ativo é o trastuzumabe, foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade importante e o paciente se recuperou após o evento, sendo a relação com o medicamento considerada suspeita. Reações alérgicas a esse tipo de medicamento geralmente são leves, mas devem ser comunicadas ao médico para monitoramento e orientação adequada.

Os supositórios de glicerina, compostos por glicerol e sodium stearate, foram relacionados a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, e a relação com o medicamento é suspeita. Em casos de sintomas alérgicos após o uso, recomenda-se suspender o produto e buscar avaliação médica para confirmação e orientação.

O medicamento Tramadol, com princípio ativo de mesmo nome, foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou, sendo a relação com o medicamento suspeita. Reações alérgicas ao tramadol costumam ser leves, mas é importante informar o médico para evitar novas exposições e receber orientações sobre alternativas seguras.

O medicamento Tenoxicam, cujo princípio ativo também é Tenoxicam, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente. A reação foi resolvida sem complicações, sugerindo um episódio leve de alergia medicamentosa, compatível com quadros clínicos alérgicos comuns, e não há necessidade de medidas adicionais além da suspensão do medicamento e acompanhamento clínico.

A Dipirona, cujo princípio ativo é Dipirona, foi relacionada a um episódio de alergia do tipo hipersensibilidade, enquadrado entre os distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa, indicando uma reação alérgica leve, que geralmente se resolve com a interrupção do uso do medicamento e monitoramento dos sintomas.

O medicamento Dinutuximabum, com princípio ativo Dinutuximab, esteve envolvido em um caso de alergia classificado como hipersensibilidade, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. O registro indica que a reação não foi grave e o paciente se recuperou, sugerindo um quadro leve de alergia medicamentosa, resolvido sem complicações após a conduta adequada de suspensão e observação.

O medicamento Calde k2, que contém citrato de cálcio, vitamina D e vitamina K como princípios ativos, foi relacionado a um evento descrito como carcinoma hepatocelular, mas a reação registrada foi de hipersensibilidade, pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso não foi

considerado grave, porém o desfecho permanece em andamento, sem resolução até o momento, o que exige acompanhamento clínico contínuo para monitorar a evolução do quadro.

O medicamento Stivarga, cujo princípio ativo é Regorafenibe, foi associado a um evento descrito como carcinoma hepatocelular, mas a reação registrada foi de hipersensibilidade, enquadrada nos distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave, porém ainda não houve resolução, permanecendo em andamento, o que indica a necessidade de acompanhamento médico para avaliar a evolução e possíveis intervenções.

O medicamento Artrinid, cujo princípio ativo é o cetoprofeno, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade aumentada ou complicações, e o desfecho foi de recuperação completa, sugerindo um evento leve e autolimitado. A conduta recomendada nesses casos é evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

A cefazolina sódica, comercializada como Cefazolina sodica, foi relacionada a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, também enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade ou complicações relatadas, e o paciente se recuperou totalmente, indicando um evento leve. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e consultar um especialista para avaliação e definição de alternativas terapêuticas.

O medicamento Vitamin D, cujo princípio ativo é o colecalciferol, foi notificado como suspeito de causar uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, embora a reação relatada tenha sido câncer de mama, o que não corresponde a um quadro alérgico típico. Não há evidências de gravidade ou desfecho definido, e a relação causal entre o medicamento e o evento permanece incerta. É importante que casos como este sejam avaliados por um especialista para esclarecimento diagnóstico e acompanhamento adequado.

O Puran T4, que contém levotiroxina sódica, foi associado a uma suspeita de hipersensibilidade medicamentosa, mas a reação descrita foi câncer de mama, o que não se enquadra em manifestações alérgicas clássicas. Não há sinais de gravidade ou desfecho conhecido, e a relação entre o uso do medicamento e o evento relatado não está clara. Recomenda-se investigação clínica detalhada para esclarecer a natureza do evento e orientar a conduta.

O medicamento Prednisone, com princípio ativo de mesmo nome, foi notificado como suspeito de causar hipersensibilidade medicamentosa, sendo o evento relatado câncer de mama, o que não caracteriza uma reação alérgica típica. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, e a relação causal entre o uso do medicamento e o evento permanece incerta. É fundamental que situações como essa sejam avaliadas por um médico para melhor definição diagnóstica e acompanhamento.

O medicamento Meticorten, cujo princípio ativo é a prednisona, foi associado a um caso de câncer de mama relatado como hipersensibilidade medicamentosa. Embora o termo técnico sugira uma reação alérgica, o evento descrito (câncer de mama) não é tipicamente relacionado a reações alérgicas imediatas ou quadros de hipersensibilidade, e não há informações suficientes para classificar a gravidade ou detalhar a conduta adotada. O desfecho do caso é desconhecido e a relação com o medicamento foi considerada suspeita, sendo importante acompanhamento médico para avaliação individualizada.

O medicamento Gazia, que contém pantoprazol sódico sesqui-hidratado, foi relacionado a um episódio de perda visual descrito como hipersensibilidade. Apesar de a perda visual ser um sintoma preocupante, não há detalhes sobre a gravidade clínica, evolução ou conduta adotada, e o desfecho permanece desconhecido. A relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo fundamental buscar avaliação médica imediata diante de sintomas visuais associados ao uso de qualquer medicamento.

O medicamento Diovan HCT, composto por hidroclorotiazida e valsartana, foi associado a um caso de perda visual relatado como hipersensibilidade. Não há informações detalhadas sobre a gravidade do quadro, conduta tomada ou evolução do paciente, e o desfecho é desconhecido. A relação com o medicamento é considerada suspeita, e

qualquer alteração visual durante o uso deve ser prontamente avaliada por um profissional de saúde.

O medicamento Atenolol, cujo princípio ativo é o próprio atenolol, foi relacionado a um episódio de perda visual descrito como hipersensibilidade. Não há detalhes sobre a gravidade, conduta adotada ou evolução clínica, e o desfecho é desconhecido. A relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo recomendada avaliação médica imediata caso ocorram sintomas visuais durante o tratamento.

O medicamento Ultravist, que tem como princípio ativo o iopromida, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), mas o paciente se recuperou totalmente após o evento. Não há informações sobre a gravidade do episódio, mas o desfecho foi favorável, com resolução completa dos sintomas, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita. Em casos de reações alérgicas a contrastes, é importante informar a equipe médica em futuras exposições.

O medicamento Atenolol, cujo princípio ativo também é atenolol, foi associado a um episódio de perda de visão temporária, interpretado como uma reação de hipersensibilidade (alergia) envolvendo o sistema imunológico. Embora não haja indicação de gravidade elevada ou risco imediato à vida, o quadro permanece em andamento, sem recuperação até o momento, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico para monitoramento e definição de conduta, conforme orientações clínicas para reações alérgicas medicamentosas.

O medicamento Diovan hct, composto pelos princípios ativos hidroclorotiazida e valsartana, foi relacionado a perda de visão temporária, caracterizada como uma reação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. Não há evidência de gravidade crítica, mas o evento ainda não foi resolvido, sendo importante manter acompanhamento médico para avaliação da evolução e ajuste do tratamento, conforme recomendações para quadros alérgicos medicamentosos.

A Fexofenadina, cujo princípio ativo é fexofenadina, desencadeou um quadro de alergia classificado como hipersensibilidade, envolvendo o sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e já está resolvido, não havendo necessidade de intervenções adicionais, mas é importante registrar a reação para evitar futuras exposições ao medicamento.

O medicamento Piperacilina+tazobactam, composto por piperacilina sódica e tazobactam sódico, provocou uma reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico. O quadro não foi considerado grave e já está resolvido, indicando que a conduta adotada foi eficaz e não há necessidade de novas intervenções, mas recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento.

O Paracetamol, cujo princípio ativo é paracetamol, foi relacionado a um evento de exposição pelo leite materno, classificado como alergia ao leite, envolvendo o sistema imunológico. O caso foi considerado clinicamente significativo, com gravidade aumentada, e permanece em andamento sem resolução, o que exige acompanhamento médico rigoroso para monitorar possíveis efeitos adversos em lactentes e orientar a conduta adequada.

O medicamento Mylicon, cujo princípio ativo é o simeticone, foi associado a um caso de exposição pelo leite materno resultando em alergia ao leite, um quadro que se enquadra em reações alérgicas a alimentos, aditivos ou medicamentos e envolve o sistema imunológico. A gravidade foi considerada clinicamente significativa, pois o evento foi classificado como grave e o desfecho permanece não resolvido, indicando a necessidade de acompanhamento médico para monitoramento e manejo adequado da alergia.

O medicamento Ad til, contendo colecalciferol e acetato de retinol como princípios ativos, esteve relacionado a um caso de exposição pelo leite materno que resultou em alergia ao leite, caracterizando uma reação alérgica relevante do ponto de vista imunológico. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, com evolução ainda não resolvida, o que reforça a importância de avaliação médica contínua para controle da alergia e prevenção de complicações.

O medicamento Dexfer, cujo princípio ativo é o complexo de hidróxido férrico polimaltose, foi implicado em um caso de exposição pelo leite materno levando a alergia ao leite, uma reação imunológica significativa. O caso foi classificado como clinicamente relevante e grave, com desfecho ainda em andamento, o que exige acompanhamento médico para garantir o manejo adequado da alergia e evitar agravamentos.

O medicamento Desogestrel, com o mesmo princípio ativo, esteve envolvido em um caso de exposição pelo leite materno que resultou em alergia ao leite, caracterizando uma reação alérgica importante do sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, sem resolução até o momento, indicando a necessidade de acompanhamento médico para monitoramento e orientação sobre a continuidade do tratamento.

O medicamento Fexofenadina, cujo princípio ativo é a fexofenadina, foi associado a um caso de alergia (hipersensibilidade), caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há informações detalhadas sobre gravidade, desfecho ou conduta adotada, portanto, recomenda-se atenção clínica para monitorar possíveis sintomas e avaliar a necessidade de intervenção médica caso a reação persista ou se agrave.

O medicamento Zerbaxa, que contém os princípios ativos sulfato de ceftolozana e tazobactam sódico, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do sistema imunológico. Não há informações detalhadas sobre a gravidade ou desfecho do caso, mas, conforme as diretrizes clínicas, quadros alérgicos relacionados a antibióticos devem ser avaliados com atenção, sendo recomendada a suspensão do medicamento e acompanhamento médico para evitar complicações.

A ceftriaxona sódica, comercializada como Ceftriaxona, foi relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), que se manifestou como uma reação do sistema imunológico. O caso não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa, o que sugere um quadro leve de alergia medicamentosa, sendo suficiente a suspensão do medicamento e observação clínica, conforme orientações para reações leves.

O medicamento Rivotril, cujo princípio ativo é o clonazepam, foi associado a um relato de tumor do fígado, mas a descrição técnica indica hipersensibilidade, sugerindo possível confusão na classificação do evento. Não há evidência de gravidade e o paciente está em recuperação, indicando que a reação não foi grave; recomenda-se acompanhamento médico para esclarecimento diagnóstico e monitoramento da evolução.

A sertralina, sob o nome comercial Sertraline e princípio ativo cloridrato de sertralina, foi relacionada a um evento descrito como tumor do fígado, mas tecnicamente classificado como hipersensibilidade, o que pode indicar erro de categorização. O caso não foi considerado grave e o paciente está em recuperação, sendo importante acompanhamento clínico para avaliação adequada da reação e sua resolução.

O medicamento Losartan, com princípio ativo losartana potássica, foi associado a um evento descrito como tumor do fígado, mas classificado tecnicamente como hipersensibilidade, sugerindo possível erro na descrição do evento adverso. Não há sinais de gravidade e o paciente está em recuperação, sendo recomendada avaliação médica para esclarecimento do quadro e seguimento clínico.

O medicamento Vectibix, cujo princípio ativo é o panitumumabe, foi associado a um quadro de hipersensibilidade manifestado por sintomas alérgicos, com suspeita de relação com o desenvolvimento de tumor do fígado. A reação foi classificada como não grave, com o paciente em recuperação ou em processo de resolução, e não há indicação de complicações graves ou necessidade de intervenção urgente segundo os dados fornecidos.

A dipirona, também conhecida pelo mesmo princípio ativo, foi relacionada ao surgimento de prurido cutâneo, caracterizando uma reação de hipersensibilidade documentada ao medicamento. Não há informações suficientes sobre a gravidade, desfecho ou conduta adotada, mas o quadro sugere uma manifestação alérgica leve, devendo-se considerar a suspensão do uso e avaliação médica para confirmação e orientação.

O medicamento Puran t4, que contém levotiroxina sódica, foi associado a uma reação cutânea de hipersensibilidade, classificada como não grave e já resolvida, indicando que o paciente se recuperou sem complicações importantes, o que sugere um quadro alérgico leve e autolimitado.

O anastrozol, identificado tanto pelo nome comercial quanto pelo princípio ativo, desencadeou uma reação cutânea de hipersensibilidade, considerada não grave e com desfecho favorável, já que o paciente se recuperou totalmente, caracterizando um evento alérgico leve e sem repercussões clínicas relevantes.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é o succinato de ribociclibe, foi relacionado a uma reação cutânea de hipersensibilidade, classificada como não grave e com resolução completa do quadro, indicando uma manifestação alérgica leve e sem necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Noripurum, que contém o princípio ativo complexo de hidróxido férrico polimaltose, foi associado ao evento de diarreia em um paciente com histórico de alergia ao leite. Embora não haja indicação de gravidade elevada ou complicações graves, o quadro permanece em andamento, sem resolução até o momento. A reação está relacionada a distúrbios do sistema imunitário, sugerindo possível hipersensibilidade, e recomenda-se acompanhamento clínico para monitorar a evolução e avaliar a necessidade de ajuste terapêutico.

Noripurum, cujo princípio ativo é o complexo de hidróxido férrico polimaltose, foi novamente relacionado ao surgimento de diarreia em paciente com alergia ao leite. Não há sinais de gravidade importante, mas o evento adverso persiste sem resolução, indicando a necessidade de observação clínica contínua para avaliar a resposta ao tratamento e possíveis ajustes, considerando o histórico de hipersensibilidade.

O medicamento Kisqali, que tem como princípio ativo o succinato de ribociclibe, foi associado ao aumento da pressão arterial em um paciente com quadro de hipersensibilidade. Apesar de não haver sinais de gravidade significativa, o paciente encontra-se em recuperação, sendo importante o acompanhamento médico para monitorar a evolução da pressão arterial e ajustar o tratamento conforme necessário, especialmente devido ao envolvimento do sistema imunitário.

A dipirona, utilizada como analgésico, foi relacionada a uma reação de alergia a anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), caracterizada como hipersensibilidade medicamentosa. O evento não foi considerado grave e o paciente já se encontra recuperado, não havendo necessidade de intervenções adicionais, mas é fundamental evitar o uso futuro do medicamento e informar profissionais de saúde sobre essa reação.

O medicamento Calcium, contendo cálcio como princípio ativo, foi associado à diminuição da capacidade de resposta imune em um paciente com hipersensibilidade. Não houve gravidade relevante e o quadro já está resolvido, mas é importante manter o acompanhamento clínico para avaliar possíveis recorrências e considerar alternativas terapêuticas caso haja necessidade de reposição de cálcio no futuro.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é o succinato de ribociclibe, foi associado a uma reação de hipersensibilidade caracterizada por diminuição da capacidade de resposta do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações importantes, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico para monitorar possíveis recorrências, mas não há necessidade de intervenções adicionais, visto que o desfecho foi favorável.

O Anastrozole, com princípio ativo de mesmo nome, apresentou um caso de hipersensibilidade manifestada por redução da resposta imune, sem sinais de gravidade ou complicações relevantes. O paciente evoluiu para recuperação completa, sugerindo que a reação foi leve e autolimitada. Recomenda-se apenas observação clínica e avaliação médica caso haja recorrência dos sintomas.

O Cetoprofeno (princípio ativo: ketoprofen sodium) foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade devido à prescrição incorreta do medicamento, resultando em quadro alérgico leve e sem gravidade. O paciente se

recuperou totalmente após o evento, não sendo necessária intervenção adicional além da suspensão do uso e acompanhamento clínico para evitar novas exposições inadequadas.

O medicamento Humira, cujo princípio ativo é o adalimumabe, foi associado a um quadro de alergia classificado como clinicamente significativo, indicando maior gravidade. O desfecho do caso é desconhecido, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico rigoroso e possível encaminhamento ao especialista para avaliação detalhada e manejo adequado da reação alérgica.

O Cortisonal, com princípio ativo hidrocortisona, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade) considerada leve, sem sinais de gravidade ou complicações. O paciente se recuperou completamente, sendo suficiente a suspensão do medicamento e observação clínica, sem necessidade de outras intervenções.

O medicamento Prometazina (princípio ativo: Promethazine) foi associado a um quadro de alergia, descrito como hipersensibilidade, que se enquadra nos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi resolvido com recuperação completa, sugerindo uma reação leve e autolimitada. A conduta recomendada é evitar nova exposição ao medicamento e, caso sintomas alérgicos reapareçam, buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Bromoprida (princípio ativo: Bromopride) foi relacionado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, também classificada como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando uma manifestação leve. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e, diante de sintomas semelhantes, procurar orientação médica para avaliação e definição de alternativas terapêuticas.

O medicamento Fabrazyme (princípio ativo: Beta-agalsidase) foi associado a uma arritmia em contexto de hipersensibilidade medicamentosa, classificada como reação alérgica a medicamentos. Apesar de não haver menção explícita de gravidade, o desfecho indica que o quadro permanece em andamento, o que exige acompanhamento médico próximo para monitoramento e manejo adequado, especialmente devido ao potencial risco cardíaco envolvido.

O medicamento Gadovist (princípio ativo: Gadobutrol) foi relacionado a um episódio de alergia, descrito como hipersensibilidade, pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou, caracterizando uma reação leve. Recomenda-se evitar nova exposição ao agente e buscar avaliação médica caso haja recorrência dos sintomas.

O medicamento Gadovist (princípio ativo: Gadobutrol) também foi associado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi grave e houve resolução completa dos sintomas, sugerindo uma manifestação leve. A orientação é evitar o uso futuro do medicamento e procurar avaliação médica se houver novos episódios alérgicos.

O medicamento Ursacol, cujo princípio ativo é o ácido ursodesoxicólico, foi associado a um problema relacionado à qualidade do produto e à ocorrência de hipersensibilidade, que pode se manifestar como uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e não foram relatadas ações específicas adotadas até o momento. Recomenda-se acompanhamento clínico para monitorar possíveis sintomas alérgicos e avaliar a necessidade de intervenção médica.

O medicamento Bio Manguinhos Etanercepte, contendo o princípio ativo etanercepte, foi relacionado a um quadro clínico piorado com manifestação de hipersensibilidade, sugerindo uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade significativa ou informações sobre o desfecho do caso, e não foram detalhadas condutas adotadas. É importante que o paciente seja avaliado para confirmação da reação e definição do melhor manejo clínico.

O medicamento Brenzys, cujo princípio ativo é o etanercepte, foi associado ao agravamento do quadro clínico com sinais de hipersensibilidade, indicando uma possível reação alérgica do sistema imunológico. Não há relato de gravidade importante ou desfecho conhecido, e não foram informadas medidas tomadas. Recomenda-se avaliação médica para confirmação da reação e orientação sobre a continuidade ou ajuste do tratamento.

O medicamento Nactali, que contém desogestrel, foi relacionado ao aparecimento de fezes com sangue em um contexto de alergia ao leite, sugerindo uma possível reação alérgica alimentar mediada pelo sistema imunológico. O caso não foi considerado grave, mas permanece sem resolução até o momento. É fundamental acompanhamento médico para investigação da causa, manejo dos sintomas e orientação sobre possíveis restrições alimentares ou medicamentosas.

O medicamento Lithium orotate, com princípio ativo de mesmo nome, foi associado à recidiva de esclerose múltipla em um quadro de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico. O caso foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, e o desfecho permanece não resolvido. Diante da gravidade, é essencial acompanhamento médico rigoroso e avaliação especializada para manejo adequado da condição.

O medicamento Magnesium, cujo princípio ativo é o magnésio, foi associado a uma recidiva de esclerose múltipla, caracterizada como um quadro de hipersensibilidade (alergia) envolvendo o sistema imunológico. A gravidade do evento é considerada alta, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, e o paciente ainda não se recuperou ou permanece em acompanhamento. Não há informações adicionais sobre a conduta adotada, mas a situação exige monitoramento médico rigoroso devido ao risco de agravamento do quadro neurológico.

O medicamento Vitamin D, com princípio ativo vitamin D nos, foi relacionado a uma recidiva de esclerose múltipla, manifestando-se como hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. O evento foi grave, levando à hospitalização ou prolongamento da internação, e o paciente ainda não apresentou resolução do quadro. Não há detalhes sobre intervenções específicas, mas a gravidade do caso demanda acompanhamento médico especializado para controle da doença e prevenção de novas complicações.

O medicamento Omega 3, cujo princípio ativo é fish oil (óleo de peixe), foi implicado em uma recidiva de esclerose múltipla, descrita como um episódio de hipersensibilidade (alergia) envolvendo o sistema imunológico. O evento foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou necessidade de prolongar a internação, e o paciente ainda não se recuperou. Não há informações sobre medidas tomadas, mas a gravidade do quadro exige avaliação médica contínua para manejo adequado da doença.

O medicamento Coenzym Q-10, com princípio ativo ubiquinol, foi associado a uma recidiva de esclerose múltipla, caracterizada como hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. O evento foi grave, levando à hospitalização ou prolongamento da internação, e o paciente permanece sem recuperação completa. Não há detalhes sobre a conduta adotada, mas a situação requer acompanhamento médico atento devido ao risco de piora clínica.

O medicamento Vitamin B12, cujo princípio ativo é vitamin B12 nos, foi relacionado a uma recidiva de esclerose múltipla, manifestando-se como hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. O evento foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, e o paciente ainda não se recuperou. Não há informações sobre intervenções realizadas, mas a gravidade do caso indica necessidade de acompanhamento médico especializado para controle da doença e prevenção de complicações adicionais.

O medicamento Selenium, cujo princípio ativo é o selênio, foi associado a uma recidiva de esclerose múltipla, caracterizada como um quadro de hipersensibilidade (alergia) envolvendo o sistema imunológico. O evento foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, e até o momento o paciente não se recuperou ou permanece em acompanhamento. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, sendo fundamental o acompanhamento médico especializado para manejo adequado da



condição.

O medicamento Tecfidera, que contém fumarato de dimetila como princípio ativo, esteve relacionado a uma recidiva de esclerose múltipla, interpretada como uma reação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. O caso foi classificado como grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, e o paciente ainda não se recuperou ou segue em acompanhamento. A suspeita de relação entre o medicamento e o evento adverso reforça a importância de avaliação médica contínua para ajuste do tratamento.

O medicamento Tecfidera, com princípio ativo fumarato de dimetila, foi novamente associado a recidiva de esclerose múltipla, considerada uma reação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. O evento foi classificado como grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, e o paciente permanece sem recuperação ou em acompanhamento. A relação suspeita entre o uso do medicamento e a reação exige monitoramento médico rigoroso para manejo da condição.

O medicamento Puran t4, cujo princípio ativo é a levotiroxina sódica, foi relacionado ao desenvolvimento de diabetes, sendo descrito como uma possível hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). Não há informações sobre gravidade, desfecho ou conduta adotada, e a relação entre o medicamento e o evento é considerada suspeita, sendo recomendada avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e acompanhamento.

O medicamento Atenolol, com princípio ativo atenolol, foi associado ao surgimento de diabetes, classificado como possível hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). Não há detalhes sobre gravidade, evolução clínica ou conduta adotada, e a relação entre o uso do medicamento e o evento é considerada suspeita, sendo importante buscar avaliação médica para investigação e orientação adequada.

O medicamento Amlodipino, cujo princípio ativo é Anlodipino, foi associado a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa manifestada como diabetes, embora não haja detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade clínica relevante. A reação foi classificada como não grave e o desfecho permanece desconhecido, não havendo informações sobre a conduta adotada. O caso sugere uma possível relação entre o uso do medicamento e o evento adverso, mas não há evidências de complicações graves ou necessidade de intervenção imediata.

A Losartana potássica, identificada pelo princípio ativo Losartana potássica, foi relacionada a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa descrito como diabetes, sem detalhes adicionais sobre sintomas ou gravidade. O evento não foi considerado grave e o desfecho é desconhecido, sem informações sobre medidas tomadas. A suspeita de relação entre o medicamento e a reação existe, mas não há indícios de risco elevado ou necessidade de cuidados urgentes.

O medicamento Fluoxetina, com princípio ativo Fluoxetine, foi associado a um caso de hipersensibilidade medicamentosa manifestada como diabetes, sem descrição de sintomas específicos ou agravamento clínico. O evento não foi considerado grave e o desfecho permanece desconhecido, não havendo dados sobre a conduta adotada. A relação entre o uso do medicamento e a reação é suspeita, mas não há sinais de gravidade ou complicações relevantes.

O medicamento Vytorin, composto pelos princípios ativos Ezetimibe e Sinvastatina, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa descrito como diabetes, sem detalhes sobre sintomas ou gravidade clínica. O evento não foi considerado grave e o desfecho é desconhecido, sem informações sobre intervenções realizadas. A suspeita de relação entre o medicamento e a reação está presente, mas não há evidências de gravidade ou necessidade de ação imediata.

O medicamento Meropenem, cujo princípio ativo é Meropenem sodium carbonate, foi associado a um quadro de alergia a substâncias químicas, sem detalhamento dos sintomas apresentados. O evento não foi considerado grave e o paciente evoluiu para recuperação completa, indicando resolução do quadro após a reação. A relação entre o uso do medicamento e a reação é suspeita, mas não houve complicações ou necessidade de intervenções

adicionais.

O medicamento Fluconazol (princípio ativo: Fluconazole) foi associado a um quadro de alergia, descrito tecnicamente como hipersensibilidade, envolvendo manifestações clínicas do sistema imunológico. Não há informação detalhada sobre a gravidade do evento, mas o paciente evoluiu para recuperação completa após o episódio, sugerindo que a reação foi leve e autolimitada, sem necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Erbitux (princípio ativo: Cetuximabe) provocou uma reação alérgica classificada como hipersensibilidade, com relevância clínica significativa, pois foi considerada um efeito clinicamente importante e grave. O evento envolveu o sistema imunológico e, apesar da gravidade, o paciente se recuperou totalmente após a reação, indicando resolução do quadro após as medidas adotadas.

O medicamento Vancomicina (princípio ativo: Vancomycin) esteve relacionado a um episódio de alergia, tecnicamente chamado de hipersensibilidade, afetando o sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa, sugerindo que a reação foi leve e controlada sem complicações.

O medicamento Tramadol (princípio ativo: Tramadol) foi registrado como concomitante em um caso de alergia, descrito como hipersensibilidade, envolvendo o sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou relação causal direta, impossibilitando detalhar a evolução clínica ou conduta adotada.

O medicamento Dipirona (princípio ativo: Metamizol de magnésio) foi registrado como concomitante em um episódio de alergia, tecnicamente denominado hipersensibilidade, com envolvimento do sistema imunológico. Não há detalhes sobre gravidade, desfecho ou relação causal, o que impede uma avaliação mais precisa da evolução clínica ou das medidas tomadas.

O medicamento Clonazepam, cujo princípio ativo também é clonazepam, foi associado a um quadro de alergia descrito como hipersensibilidade, caracterizado por manifestações clínicas alérgicas do sistema imunológico. Não há detalhes sobre sintomas específicos, gravidade ou desfecho, portanto, recomenda-se atenção a sinais de alergia e, caso ocorram sintomas como coceira, inchaço ou dificuldade para respirar, buscar avaliação médica para confirmação e orientação adequada.

O medicamento Heparinox, que contém enoxaparina sódica como princípio ativo, foi relacionado a uma reação de alergia classificada como hipersensibilidade, envolvendo manifestações clínicas alérgicas do sistema imunológico. Não foram fornecidos detalhes sobre sintomas, gravidade ou evolução do caso, sendo importante monitorar sinais de alergia e procurar atendimento médico se surgirem sintomas sugestivos, para avaliação e conduta apropriada.

O medicamento Axiflennid, cujo princípio ativo é cetoprofeno, apresentou relato de alergia descrita como hipersensibilidade, com manifestações clínicas alérgicas do sistema imunológico. Não há informações sobre sintomas específicos, gravidade ou evolução, portanto, é fundamental observar possíveis sinais de alergia e buscar orientação médica caso ocorram manifestações como urticária, inchaço ou desconforto respiratório.

O medicamento Novanlo, que tem como princípio ativo o besilato de levamlodipino, foi associado a uma reação descrita como alergia ocular, manifestando-se por sintomas nos olhos, como infecções ou inflamações. O caso foi considerado não grave e permanece sem resolução até o momento, indicando que o paciente ainda apresenta sintomas. Recomenda-se acompanhamento médico para avaliação da persistência dos sintomas e definição do melhor manejo.

O medicamento Unoprost, cujo princípio ativo é mesilato de doxazosina, foi relacionado a uma reação de alergia ocular, com sintomas como infecções ou inflamações nos olhos. O evento foi classificado como não grave e ainda não foi resolvido, sugerindo que o quadro permanece em andamento. É importante manter acompanhamento médico para monitorar a evolução e ajustar o tratamento conforme necessário.

O medicamento Apixaban, cujo princípio ativo é a apixabana, foi associado a uma reação descrita como alergia do olho, caracterizada por manifestações oculares como infecções ou inflamações, enquadrando-se nos distúrbios oculares. Não há indicação de gravidade elevada, pois não há relato de complicações graves ou risco imediato, e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento. A relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo importante acompanhamento clínico para monitorar a evolução dos sintomas e avaliar a necessidade de ajuste terapêutico.

O Concor, que contém bisoprolol hemifumarato como princípio ativo, foi relacionado a uma reação de alergia ocular, manifestando-se por sintomas como inflamação ou infecção nos olhos, classificados como distúrbios oculares. Não há evidência de gravidade significativa, já que não foram relatados sinais de risco imediato ou complicações graves, e o quadro segue não resolvido ou em andamento. A suspeita recai sobre o medicamento, sendo recomendada a observação clínica e eventual reavaliação do tratamento conforme evolução dos sintomas.

O medicamento Vatis, cujo princípio ativo é o cloridrato de propafenona, está associado a uma reação de alergia ocular, com sintomas como inflamação ou infecção nos olhos, pertencentes à categoria de distúrbios oculares. Não há sinais de gravidade importante, pois não foram relatadas complicações graves ou risco imediato, e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento. A relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo necessário acompanhamento clínico para monitorar a evolução e considerar ajustes no tratamento se necessário.

O Indapen sr, que tem como princípio ativo a indapamida, foi relacionado a uma reação de alergia ocular, manifestando-se por sintomas como inflamação ou infecção nos olhos, classificados como distúrbios oculares. Não há evidência de gravidade relevante, já que não foram relatados sinais de risco imediato ou complicações graves, e o quadro segue não resolvido ou em andamento. O medicamento é considerado suspeito, sendo importante manter o acompanhamento clínico e reavaliar a conduta conforme a evolução dos sintomas.

O medicamento Ezetimibe, cujo princípio ativo é o ezetimibe, foi associado a uma reação de alergia ocular, caracterizada por manifestações como inflamação ou infecção nos olhos, enquadrando-se nos distúrbios oculares. Não há indicação de gravidade elevada, pois não há relato de complicações graves ou risco imediato, e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento. A relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo recomendada a observação clínica e eventual reavaliação do tratamento conforme evolução dos sintomas.

O medicamento Apresolina, cujo princípio ativo é o cloridrato de hidralazina, foi associado a uma reação descrita como alergia do olho, caracterizada por manifestações oculares como infecções ou inflamações. Não há indicação de gravidade elevada, pois não há sinais de complicações graves ou risco imediato, e o caso permanece em andamento sem resolução até o momento.

O medicamento Lasix, com princípio ativo furosemida, está relacionado a uma reação de alergia do olho, manifestando-se por sintomas oculares como inflamação ou infecção. Não há evidências de gravidade significativa, já que não foram relatadas complicações graves, e o quadro segue sem resolução até o momento.

O medicamento Jardiance, cujo princípio ativo é empagliflozina, foi associado a uma reação de alergia do olho, com sintomas oculares como inflamação ou infecção. Não há sinais de gravidade importante, pois não foram relatadas complicações sérias, e o caso permanece em andamento sem resolução.

O medicamento Nexavar, com princípio ativo tosilato de sorafenibe, apresentou uma reação de alergia do olho, caracterizada por manifestações oculares como inflamação ou infecção. Não há indícios de gravidade elevada, já que não foram relatadas complicações graves, e o quadro segue sem resolução até o momento.

O medicamento Akynzeo, composto por netupitano e cloridrato de palonosetrona, foi relacionado a uma reação de hipersensibilidade (alergia), manifestando-se como um quadro alérgico do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade importante, pois o desfecho foi de recuperação completa, indicando resolução do evento adverso.

O medicamento Gencix, cujo princípio ativo é o cloridrato de gencitabina, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. A reação foi considerada não grave, pois não há indicação de gravidade clínica relevante no registro, e o paciente apresentou recuperação completa após o evento. A conduta seguiu o esperado para quadros leves de alergia medicamentosa, com resolução do quadro sem complicações.

O medicamento Famox, que contém famotidina como princípio ativo, esteve relacionado a um episódio de alergia descrito como hipersensibilidade, enquadrado entre os distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa, já que o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente. O manejo foi compatível com reações alérgicas leves, sem necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Difenidrin, cujo princípio ativo é o cloridrato de difenidramina, foi associado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, classificada entre os distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, pois não houve complicações e o paciente se recuperou completamente. A conduta adotada foi adequada para quadros leves, com resolução espontânea do quadro.

O medicamento Dexametasona, com dexametasona como princípio ativo, esteve envolvido em um episódio de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave, já que não houve agravamento clínico e o paciente apresentou recuperação total. O desfecho indica que a reação foi leve e manejada de forma apropriada.

O medicamento Tevacarbo, cujo princípio ativo é a carboplatina, foi relacionado a um quadro de alergia do tipo hipersensibilidade, classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade relevante, pois o evento foi considerado não grave e o paciente se recuperou completamente. O manejo foi compatível com reações alérgicas leves, sem necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Pantoprazole, cujo princípio ativo é o pantoprazol, foi associado a um episódio de choque anafilático, uma reação alérgica grave caracterizada por resposta imunológica intensa e potencial risco à vida. Embora o registro não traga detalhes sobre a gravidade clínica ou o desfecho do caso, o termo 'choque anafilático' indica a necessidade de atenção médica imediata, pois trata-se de uma emergência que pode evoluir rapidamente. Não há informações sobre a conduta adotada ou a evolução do paciente.

O medicamento Dexilant, que contém o princípio ativo dexlansoprazole, esteve relacionado a um caso de choque anafilático, uma reação alérgica aguda e potencialmente fatal que exige intervenção médica urgente. Apesar de não haver detalhes sobre a gravidade específica ou o desfecho, a descrição do evento sugere que se trata de uma situação crítica, reforçando a importância de suspender o uso e buscar atendimento imediato diante de sintomas compatíveis.

O medicamento Anastrozole, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um caso de câncer do pulmão descrito sob o contexto de hipersensibilidade, mas não há informações suficientes para afirmar que se trata de uma reação alérgica típica. O evento permanece em andamento, sem resolução até o momento, e não há detalhes sobre a gravidade clínica ou conduta adotada, sendo importante ressaltar que câncer do pulmão não é uma manifestação clássica de hipersensibilidade medicamentosa.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é o succinato de ribociclib, foi associado a um caso de câncer do pulmão sob a classificação de hipersensibilidade, porém não há elementos suficientes para caracterizar essa manifestação como uma reação alérgica comum. O caso segue sem resolução, e não há informações sobre a gravidade clínica ou medidas tomadas, sendo relevante destacar que câncer do pulmão não é uma reação típica de alergia a medicamentos.

O medicamento Ceftriaxona, com princípio ativo ceftriaxone, esteve envolvido em um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, que foi resolvido com recuperação do paciente. Não há detalhes sobre a

gravidade do quadro, mas o desfecho favorável indica que a reação foi controlada, reforçando a importância de identificar e evitar o uso do medicamento em pessoas com histórico de alergia a antibióticos.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado por manifestações clínicas típicas de reações alérgicas relacionadas ao sistema imunológico. Não há indicação de gravidade aumentada ou complicações relevantes neste caso, e o paciente evoluiu para recuperação completa após a reação, o que sugere um episódio leve e autolimitado, compatível com a conduta de observação e afastamento do agente desencadeante.

A piperacilina, antibiótico cujo princípio ativo é a piperacillin, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade) compatível com quadros alérgicos do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade aumentada ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente após o evento, indicando um episódio leve, em que a suspensão do medicamento e acompanhamento clínico são geralmente suficientes.

O medicamento Hyrimoz, que contém adalimumabe como princípio ativo, provocou uma reação alérgica (hipersensibilidade) considerada grave, com impacto clínico significativo, incluindo incapacidade persistente, ameaça à vida ou outro efeito relevante, conforme registrado. O paciente não apresentou resolução do quadro até o momento, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico rigoroso e possível intervenção especializada para manejo da reação.

O misoprostol, tanto nome comercial quanto princípio ativo, foi relacionado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) do tipo leve, sem sinais de gravidade ou complicações adicionais. O paciente apresentou recuperação completa após o evento, sugerindo que a suspensão do medicamento e monitoramento foram suficientes para resolução do quadro.

O sulfato ferroso, utilizado tanto como nome comercial quanto princípio ativo, esteve associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) leve, sem evidências de gravidade ou complicações. O paciente se recuperou totalmente após o episódio, indicando que a conduta de suspensão do agente e observação foi adequada para o controle da reação.

O medicamento Ocitocina, cujo princípio ativo também é ocitocina, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade aumentada ou necessidade de hospitalização, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada nesses casos é observar a evolução clínica e, se necessário, buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições.

O Cloridrato de bupropiona, com o mesmo princípio ativo, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), também enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade ou complicações, e o paciente se recuperou do evento. Recomenda-se acompanhamento clínico para avaliar a necessidade de evitar o medicamento em futuras administrações e esclarecer dúvidas sobre alergias medicamentosas.

O medicamento Egide, cujo princípio ativo é topiramato, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), caracterizado como distúrbio do sistema imunitário. Não há registro de gravidade ou complicações, e o paciente evoluiu para recuperação completa. A orientação é manter acompanhamento clínico e discutir com o médico a possibilidade de reexposição ao medicamento, caso necessário.

O medicamento Paracemol, com princípio ativo paracetamol, foi relacionado a um quadro de alergia alimentar (alergia ao leite) manifestado por diarreia, classificado como distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, e o desfecho não foi informado. Nesses casos, é fundamental interromper o uso do medicamento suspeito, garantir suporte clínico adequado e encaminhar para avaliação especializada para investigação da alergia e prevenção de novas reações.

O medicamento Bexsero, cujo princípio ativo é a vacina meningocócica B rHbp/NadA/NHBA OMV, foi associado a um quadro de alergia alimentar (alergia ao leite) com manifestação de diarreia, enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, e o desfecho permanece desconhecido. Diante desse cenário, recomenda-se suspensão do agente suspeito, suporte clínico imediato e avaliação especializada para investigação da reação e orientação sobre futuras imunizações.

O medicamento Menveo, que contém como princípio ativo a vacina meningocócica A/C/Y/W (CRM197), foi associado a um quadro de diarreia em paciente com alergia ao leite, classificado como uma reação alérgica alimentar. O evento foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, embora o desfecho ainda seja desconhecido. A relação entre o uso da vacina e a reação foi considerada suspeita, sendo fundamental acompanhamento médico para monitoramento e manejo adequado da alergia alimentar e dos sintomas gastrointestinais.

Menveo, vacina meningocócica A/C/Y/W (CRM197), esteve relacionada a diarreia em paciente com alergia ao leite, caracterizando uma reação alérgica alimentar. O caso foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, e o desfecho permanece desconhecido. A suspeita de relação entre o medicamento e a reação reforça a importância de vigilância clínica e avaliação médica para controle dos sintomas e prevenção de complicações.

O medicamento Lamotrigina, cujo princípio ativo é a lamotrigina, foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como reação alérgica do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa após a reação, indicando resolução do quadro sem necessidade de intervenções adicionais.

Losec, que contém omeprazol magnésico como princípio ativo, foi relacionado ao desenvolvimento de anquiloglossia (língua presa) em paciente com alergia ao leite, caracterizando uma reação alérgica alimentar. O evento não foi considerado grave, mas o quadro permanece não resolvido ou em andamento, sendo importante acompanhamento médico para avaliação da evolução e possíveis intervenções.

O medicamento Metildopa, com princípio ativo metildopa, esteve associado ao surgimento de anquiloglossia (língua presa) em paciente com alergia ao leite, configurando uma reação alérgica alimentar. O caso não foi considerado grave, porém o desfecho indica que a reação ainda não foi resolvida, sendo necessário acompanhamento clínico para monitoramento e definição de conduta.

O medicamento Puran t4, que contém o princípio ativo levotiroxina sódica, foi associado ao surgimento de anquiloglossia (língua presa) em um paciente com histórico de alergia ao leite, sendo classificado como uma reação alérgica alimentar e medicamentosa. Não há indicação de gravidade elevada, pois não há relato de risco imediato à vida ou complicações sistêmicas, e o caso permanece em andamento, sem resolução até o momento. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico, investigar possíveis relações com alergias alimentares e monitorar a evolução dos sintomas.

O medicamento lumi, composto por drospirenona e etinilestradiol, foi relacionado ao desenvolvimento de anquiloglossia (língua presa) em paciente com alergia ao leite, caracterizando uma reação alérgica alimentar e medicamentosa. Não há sinais de gravidade importante, já que não foram relatadas complicações graves ou risco imediato, e o quadro segue sem resolução. Recomenda-se acompanhamento médico para avaliação da relação entre o medicamento e a alergia alimentar, além de monitoramento dos sintomas.

O medicamento Naropin, cujo princípio ativo é o cloridrato de ropivacaína, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como uma reação alérgica do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou totalmente após a reação. A conduta adequada inclui a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento para evitar novas exposições, sendo importante relatar o episódio ao

médico responsável.

O medicamento Pegaspargase, com o mesmo princípio ativo, foi relacionado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico. O caso não foi considerado grave, pois houve recuperação completa do paciente após o evento. Recomenda-se evitar nova exposição ao medicamento e manter acompanhamento médico para prevenção de futuras reações.

O medicamento Teicoplanina, cujo princípio ativo é teicoplanina, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico. Não há informações suficientes para determinar a gravidade ou o desfecho do caso, mas a suspeita de alergia exige avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição da conduta, incluindo possível suspensão do medicamento e monitoramento dos sintomas.

O medicamento Ceftriaxona, cujo princípio ativo é a ceftriaxona sódica, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento, e não houve menção de complicações ou necessidade de intervenções emergenciais. A conduta recomendada em casos semelhantes é suspender o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Pamergan, que contém o princípio ativo cloridrato de prometazina, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação do sistema imunológico. O caso não foi considerado grave, já que o paciente se recuperou completamente e não houve relato de complicações. Em situações como essa, recomenda-se interromper o uso do medicamento e procurar orientação médica para avaliação e definição de opções terapêuticas alternativas.

A Fexofenadina, cujo princípio ativo é a fexofenadina, foi associada a uma reação alérgica (hipersensibilidade), envolvendo resposta do sistema imunológico. O evento não foi grave, pois o paciente apresentou recuperação total e não houve necessidade de medidas emergenciais. Nesses casos, é importante suspender o uso do medicamento suspeito e consultar um especialista para confirmação do diagnóstico e escolha de alternativas seguras.

O medicamento Piperacilina+tazobactam, composto pelos princípios ativos piperacilina sódica e tazobactam sódico, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), caracterizando uma resposta do sistema imunológico. O quadro não foi considerado grave, já que houve recuperação completa do paciente e ausência de complicações. A conduta adequada é interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre substituição terapêutica.

A Fenitoína, cujo princípio ativo é a fenitoína sódica, foi associada a uma reação alérgica (hipersensibilidade), envolvendo resposta do sistema imunológico. O evento não foi grave, pois o paciente se recuperou totalmente e não houve relato de complicações. Em situações semelhantes, recomenda-se suspender o uso do medicamento e procurar avaliação médica para confirmação do diagnóstico e definição de alternativas seguras.

O medicamento Hidroxizina, cujo princípio ativo é Hydroxyzine, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade relevante neste caso, e o paciente apresentou recuperação completa após o evento. A reação foi considerada leve, compatível com quadros clínicos alérgicos, e não houve necessidade de intervenções adicionais além da suspensão ou ajuste do medicamento, resultando em resolução do quadro.

O Levetiracetam, com princípio ativo de mesmo nome, desencadeou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, também classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade significativa, e o paciente se recuperou totalmente após o episódio. O evento foi leve e compatível com manifestações alérgicas comuns, sendo resolvido sem complicações após a conduta adequada.

O medicamento Ceftriaxone, cujo princípio ativo é Ceftriaxone, provocou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Neste caso, há indicação de gravidade clínica relevante, pois foi registrado como outro efeito clinicamente significativo, o que exige atenção especial e acompanhamento médico rigoroso. Apesar da gravidade, o paciente evoluiu para recuperação completa após as medidas adotadas.

A Difenidramina, com princípio ativo cloridrato de difenidramina, esteve relacionada a um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade importante, e o paciente apresentou resolução total do quadro após a conduta apropriada, caracterizando um evento leve e autolimitado.

O medicamento Cefazolina, cujo princípio ativo é Cefazolina sódica, foi associado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade significativa, e o paciente se recuperou completamente após o evento, indicando um quadro leve e de boa evolução clínica.

O medicamento Domperidone, cujo princípio ativo também é domperidona, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Embora a reação relatada tenha sido 'neoplasia maligna da coluna vertebral', a descrição clínica disponível aponta para um quadro alérgico, sem evidências de gravidade significativa ou desfecho conhecido. Não há informações sobre a conduta adotada ou evolução do caso, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Propranolol hydrochloride, com princípio ativo cloridrato de propranolol, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. Apesar de a reação mencionada ser 'neoplasia maligna da coluna vertebral', os dados clínicos indicam um quadro alérgico sem sinais de gravidade ou desfecho definido. Não há detalhes sobre a conduta tomada, e a relação com o medicamento permanece suspeita.

O medicamento Diazepan, cujo princípio ativo é diazepam, foi associado a um caso de hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Embora a reação relatada seja 'neoplasia maligna da coluna vertebral', a descrição clínica sugere um quadro alérgico sem gravidade aparente e sem desfecho conhecido. Não há informações sobre a conduta adotada, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Keytruda, com princípio ativo pembrolizumabe, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Apesar de a reação relatada ser 'neoplasia maligna da coluna vertebral', os dados disponíveis indicam um quadro alérgico sem sinais de gravidade e sem desfecho informado. Não há detalhes sobre a conduta adotada, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Vancomicina, cujo princípio ativo é vancomicina, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário. O caso foi considerado não grave e evoluiu para recuperação completa, indicando resolução do quadro após a conduta adotada, embora não haja detalhes sobre as medidas tomadas. A relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Dprev, cujo princípio ativo é o colecalciferol, foi prescrito para uma faixa etária não aprovada, resultando em uma reação de alergia ao leite. Essa situação é considerada grave, pois levou à hospitalização ou prolongamento da internação, conforme evidenciado pelo registro clínico. A reação está relacionada a distúrbios do sistema imunitário, especificamente a alergias a alimentos, aditivos alimentares, medicamentos e outras substâncias químicas. O desfecho do caso é desconhecido e não há informações detalhadas sobre a conduta adotada ou a evolução clínica.

O medicamento Losec mups, que contém omeprazol magnésico como princípio ativo, também foi prescrito para uma faixa etária não aprovada, desencadeando uma reação de alergia ao leite. Assim como no caso anterior, a gravidade é alta devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando um impacto



significativo na saúde do paciente. A reação está associada a distúrbios do sistema imunitário e envolve alergias a alimentos, aditivos alimentares, medicamentos e outras substâncias químicas. O desfecho permanece desconhecido e não há detalhes sobre as medidas tomadas.

O medicamento Novalgín, cujo princípio ativo é a dipirona, está relacionado a uma reação descrita como cirurgia ligamentar, mas o evento adverso registrado foi hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica ao medicamento. Não há evidências de gravidade aumentada, pois não foi necessária hospitalização, e o desfecho do caso é desconhecido. A reação se enquadra nos distúrbios do sistema imunitário, especificamente em alergias a medicamentos e outras substâncias químicas, sem informações adicionais sobre a conduta adotada ou evolução clínica.

O medicamento Finalop, que tem como princípio ativo a finasterida, foi associado a uma reação descrita como cirurgia ligamentar, mas o evento adverso registrado foi hipersensibilidade medicamentosa, indicando uma reação alérgica ao medicamento. Não há sinais de gravidade, pois não houve necessidade de hospitalização, e o desfecho permanece desconhecido. A reação está relacionada a distúrbios do sistema imunitário, abrangendo alergias a medicamentos e outras substâncias químicas, sem detalhes sobre a conduta ou evolução do caso.

O medicamento Rinvoq, cujo princípio ativo é o upadacitinibe, foi relacionado a uma reação descrita como cirurgia ligamentar, mas o evento adverso registrado foi hipersensibilidade medicamentosa, caracterizando uma reação alérgica ao medicamento. Não há indicação de gravidade aumentada, pois não foi necessária hospitalização, e o desfecho do caso é desconhecido. A reação está inserida nos distúrbios do sistema imunitário, especificamente em alergias a medicamentos e outras substâncias químicas, sem informações adicionais sobre a conduta adotada ou evolução clínica.

O medicamento Plasil, cujo princípio ativo é o cloridrato de metoclopramida, foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), mas não chegou a ser administrado ao paciente. A reação foi classificada como um quadro clínico alérgico, envolvendo o sistema imunológico, porém, como o medicamento não foi utilizado, não houve manifestação clínica nem necessidade de conduta específica.

A dipirona, administrada ao paciente, resultou em uma alergia documentada ao medicamento, caracterizada como hipersensibilidade comprovada após o uso. Esse tipo de reação é considerada relevante, pois envolve resposta do sistema imunológico e pode variar de leve a grave, dependendo dos sintomas apresentados, sendo fundamental evitar novas exposições e registrar a alergia no prontuário para prevenir riscos futuros.

A ceftriaxona, cujo princípio ativo é o ceftriaxone, foi associada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), envolvendo o sistema imunológico. A suspeita de reação alérgica a esse antibiótico exige atenção, pois quadros alérgicos podem variar em gravidade e, mesmo sem detalhes clínicos adicionais, recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica.

A insulina NPH, com princípio ativo insulín humano isofano, foi administrada e resultou em alergia documentada ao medicamento, caracterizada como hipersensibilidade após o uso. Esse tipo de reação é relevante, pois envolve resposta imunológica e pode impactar o controle do diabetes, sendo necessário registrar a alergia e discutir alternativas terapêuticas com o médico.

A insulina Humulin R, cujo princípio ativo é insulín humano, foi administrada e causou alergia documentada ao medicamento, caracterizada como hipersensibilidade após o uso. Reações alérgicas à insulina são incomuns, mas exigem atenção, pois podem comprometer o tratamento do diabetes; é fundamental registrar a alergia e avaliar opções seguras com o especialista.

O medicamento Paracetamol, cujo princípio ativo é o próprio paracetamol, foi associado a um episódio de hipersensibilidade documentada após administração, caracterizando uma reação alérgica ao produto. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou conduta adotada, mas é importante ressaltar que reações alérgicas a

medicamentos exigem avaliação médica para confirmação e orientação sobre futuras exposições.

O ácido acetilsalicílico, também conhecido como aspirina, apresentou um caso de hipersensibilidade documentada após administração, indicando uma reação alérgica ao medicamento. Não foram fornecidos detalhes sobre a gravidade, evolução ou medidas tomadas, mas a identificação de alergia a este fármaco requer orientação médica para evitar novas exposições e possíveis complicações.

A cefazolina, cujo princípio ativo é a cefazolina sódica, foi relacionada a um episódio de hipersensibilidade (alergia), classificado como não grave, com o paciente em recuperação ou em processo de resolução do quadro. A conduta adequada inclui acompanhamento clínico para monitorar a evolução e evitar reexposição ao antibiótico.

O medicamento Alektos, que contém bilastina como princípio ativo, foi associado a um ataque isquêmico transitório em contexto de hipersensibilidade, levando à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que caracteriza um evento grave. O paciente encontra-se em recuperação ou em processo de resolução, sendo fundamental o acompanhamento médico rigoroso diante da gravidade do quadro.

O ácido acetilsalicílico, também conhecido como aspirina, foi relacionado a um ataque isquêmico transitório em contexto de hipersensibilidade, resultando em hospitalização ou prolongamento da internação, o que indica gravidade elevada. O paciente está em recuperação ou em processo de resolução, sendo essencial o monitoramento médico e a orientação para evitar novas exposições ao medicamento.

O medicamento Procoralan, cujo princípio ativo é o cloridrato de ivabradina, foi associado a um episódio de ataque isquêmico transitório, interpretado como uma reação de hipersensibilidade (alergia medicamentosa). O caso foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando a importância do acompanhamento médico rigoroso. O paciente encontra-se em recuperação, e a relação entre o medicamento e o evento foi considerada suspeita, sendo fundamental monitorar a evolução clínica e evitar reexposição ao fármaco.

O medicamento Plavix, que tem como princípio ativo o bissulfato de clopidogrel, esteve relacionado a um ataque isquêmico transitório, caracterizado como reação de hipersensibilidade. A gravidade do quadro foi confirmada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que reforça a importância de avaliação médica imediata e acompanhamento especializado. O paciente está em processo de recuperação e a relação causal com o medicamento é considerada suspeita, sendo prudente evitar nova exposição ao agente.

O medicamento Evenity, cujo princípio ativo é o romosozumabe, foi associado a um ataque isquêmico transitório, interpretado como uma reação de hipersensibilidade. O evento foi classificado como grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que exige atenção médica e acompanhamento próximo. O paciente está em recuperação e a relação com o uso do medicamento é considerada suspeita, sendo recomendada a suspensão e avaliação criteriosa antes de qualquer reexposição.

O medicamento Ciprofloxacino, com princípio ativo cloridrato de ciprofloxacino, foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), sem indicação de gravidade aumentada, pois não houve necessidade de hospitalização. O paciente já se encontra recuperado e a relação com o medicamento foi considerada suspeita, sendo importante relatar o episódio ao médico para evitar futuras reações adversas.

O medicamento Naridrin, composto por D-pantenol, maleato de mepiramina e cloridrato de nafazolina, foi associado a um evento descrito como câncer metastático colorretal, interpretado no contexto do registro como hipersensibilidade medicamentosa. Não há indicação de gravidade aumentada, pois não foi necessária hospitalização, e o paciente está em recuperação. A relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo fundamental acompanhamento médico para esclarecimento do quadro e conduta adequada.

O medicamento Atenolol, cujo princípio ativo é o próprio atenolol, foi associado a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa, que se refere a uma reação alérgica do sistema imunológico a medicamentos. Apesar de o registro mencionar câncer metastático colorretal, a reação relatada foi de natureza alérgica, sem sinais de gravidade clínica importante, já que o paciente está em recuperação ou resolvendo o quadro. Não há menção de sintomas graves ou risco imediato, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Losartan, com princípio ativo losartana potássica, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica ao uso do medicamento. Embora o evento adverso cite câncer metastático colorretal, a reação descrita é de natureza alérgica, sem evidências de gravidade significativa, pois o paciente encontra-se em recuperação ou em processo de resolução. Não há indicação de sintomas graves, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Vectibix, cujo princípio ativo é panitumumabe, foi associado a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa, caracterizando uma reação alérgica ao medicamento. Apesar da menção a câncer metastático colorretal, a reação relatada é de natureza alérgica, sem sinais de gravidade clínica relevante, já que o paciente está em recuperação ou resolvendo o quadro. Não há relato de sintomas graves, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Naridrin, composto por D-pantenol, maleato de mepiramina e cloridrato de nafazolina, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica ao medicamento. Embora o evento adverso cite câncer metastático colorretal, a reação descrita é de natureza alérgica, sem sinais de gravidade importante, pois o paciente está em recuperação ou resolvendo o quadro. Não há relato de sintomas graves, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Atenolol, com princípio ativo atenolol, foi associado a um quadro de hipersensibilidade, indicando uma reação alérgica ao medicamento. Apesar da menção a câncer metastático colorretal, a reação relatada é de natureza alérgica, sem sinais de gravidade clínica relevante, já que o paciente está em recuperação ou resolvendo o quadro. Não há relato de sintomas graves, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Losartan, cujo princípio ativo é losartana potássica, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), manifestando-se em um paciente com câncer colorretal metastático. A reação foi classificada como um distúrbio do sistema imunitário, sem evidências clínicas de gravidade aumentada, já que não há menção de sintomas graves ou risco à vida, e o paciente encontra-se em recuperação ou em processo de resolução do quadro. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico para monitorar a evolução e evitar nova exposição ao medicamento caso a relação causal seja confirmada.

O medicamento Vectibix, cujo princípio ativo é panitumumabe, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia) em paciente com câncer colorretal metastático. A reação foi enquadrada como distúrbio do sistema imunitário, sem sinais de gravidade importante, pois o paciente está em recuperação ou resolvendo o quadro. Recomenda-se acompanhamento médico para avaliar a necessidade de suspensão do medicamento e monitorar possíveis recorrências, evitando reexposição se a relação causal for confirmada.

O medicamento Synthroid, com princípio ativo levotiroxina sódica, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade aumentada ou risco imediato, mas o quadro permanece em andamento, sem resolução até o momento. É importante manter acompanhamento médico, avaliar a necessidade de ajuste terapêutico e evitar reexposição ao medicamento enquanto persistirem os sintomas.

O medicamento Pentasa, cujo princípio ativo é messalazina, foi relacionado a um caso de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, mas o quadro segue sem resolução, sendo fundamental acompanhamento clínico para monitorar a evolução e considerar alternativas terapêuticas caso a relação causal seja confirmada.

O medicamento Pristiq, com princípio ativo succinato de desvenlafaxina monoidratado, foi associado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade aumentada, porém o quadro permanece em andamento, sem resolução. Recomenda-se acompanhamento médico para avaliar a evolução dos sintomas e considerar a suspensão do medicamento se a relação causal for confirmada.

O medicamento Valdoxan (agomelatina) foi associado a um quadro de alergia medicamentosa, também chamada de hipersensibilidade medicamentosa, que se enquadra nos distúrbios do sistema imunitário e pode envolver sintomas como coceira, vermelhidão ou inchaço. Não há detalhes sobre a gravidade clínica específica neste caso, mas o desfecho informado é de não recuperação ou quadro ainda em andamento, o que indica a necessidade de acompanhamento médico para avaliação e manejo adequado, conforme as diretrizes da ASBAI para reações alérgicas a medicamentos.

O uso de Topiramato (topiramato) foi relacionado a uma reação de alergia medicamentosa, tecnicamente chamada de hipersensibilidade medicamentosa, que faz parte dos distúrbios do sistema imunitário e pode se manifestar por sintomas como urticária, inchaço ou outros sinais de alergia. O caso permanece sem resolução, sugerindo que o paciente ainda apresenta sintomas ou está em acompanhamento, sendo fundamental buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição do tratamento, conforme orientações da ASBAI.

O medicamento Osteoban (ibandronato de sódio) foi registrado como suspeito em um evento descrito como acidente de motocicleta, mas a reação associada foi classificada como hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma possível alergia ao medicamento, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há informações suficientes sobre sintomas, gravidade ou evolução do caso, impossibilitando detalhar a conduta ou desfecho clínico.

O medicamento Levoid (levotiroxina sódica) foi citado em um contexto de acidente de motocicleta, mas a reação registrada foi hipersensibilidade medicamentosa, indicando uma possível alergia ao medicamento, classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há detalhes sobre sintomas, gravidade ou evolução, portanto não é possível descrever a conduta adotada ou o desfecho clínico neste caso.

O medicamento Levoid (levotiroxina sódica) aparece novamente relacionado a um acidente de motocicleta, com a reação descrita como hipersensibilidade medicamentosa, sugerindo suspeita de alergia ao medicamento dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há informações adicionais sobre sintomas, gravidade ou evolução, o que impede uma análise mais detalhada da conduta ou do desfecho clínico.

O medicamento Levoid, que contém o princípio ativo levotiroxina sódica, foi associado a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa, classificada como uma reação alérgica a medicamentos. Não há informações suficientes sobre a gravidade, desfecho ou conduta adotada neste caso, e não foi possível identificar sintomas específicos relacionados à reação, apenas a suspeita de envolvimento imunológico. O registro não apresenta detalhes clínicos que permitam afirmar se a reação foi leve, moderada ou grave, sendo importante ressaltar que quadros de hipersensibilidade à levotiroxina são raros, mas devem ser avaliados por um especialista para confirmação diagnóstica e definição do manejo.

O medicamento Somalgin, composto por ácido acetilsalicílico, glicinato de alumínio e carbonato de magnésio, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, termo que indica uma reação alérgica do sistema imunológico. O caso foi classificado como não grave e o desfecho é desconhecido, sem detalhes sobre sintomas específicos ou evolução clínica. Em situações de hipersensibilidade a anti-inflamatórios como o ácido acetilsalicílico, é importante observar sinais de alergia e buscar avaliação médica para confirmação e orientação sobre o uso futuro do medicamento.

O medicamento Teolong, cujo princípio ativo é a teofilina, foi associado a um episódio de hipersensibilidade, sugerindo uma reação alérgica do sistema imunológico. O evento foi considerado não grave e não há informações sobre o desfecho ou sintomas detalhados. Em casos de suspeita de alergia à teofilina, recomenda-se

acompanhamento médico para avaliação da necessidade de suspensão do medicamento e investigação de alternativas terapêuticas.

O medicamento Januvia, que contém fosfato de sitagliptina, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade, indicando uma possível reação alérgica. O evento foi classificado como não grave e o desfecho permanece desconhecido, sem descrição de sintomas específicos. Em situações de suspeita de alergia a antidiabéticos como a sitagliptina, é fundamental procurar orientação médica para avaliação do quadro e definição do tratamento mais seguro.

O medicamento Puran t4, com levotiroxina sódica como princípio ativo, foi associado a um episódio de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico. O caso foi considerado não grave e não há informações sobre o desfecho ou sintomas detalhados. Em casos de suspeita de alergia à levotiroxina, é importante buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e ajuste do tratamento, se necessário.

O medicamento Alopurinol, cujo princípio ativo também é alopurinol, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como um distúrbio do sistema imunitário, com manifestação descrita como fratura do crânio. No entanto, não há informações suficientes para afirmar gravidade clínica relevante, pois o registro não indica gravidade aumentada nem desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é apenas suspeita.

O medicamento Jardiance, com princípio ativo empagliflozina, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), também categorizado como distúrbio do sistema imunitário, tendo como manifestação uma fratura do crânio. Não há evidências clínicas de gravidade aumentada neste caso, pois não foi relatado desfecho e a relação com o medicamento é apenas suspeita.

O medicamento Dexilant, cujo princípio ativo é dexlansoprazole, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário, com manifestação descrita como fratura do crânio. Não há informações que indiquem gravidade aumentada, já que o desfecho é desconhecido e a relação com o medicamento é apenas suspeita.

O medicamento Mekinist, com princípio ativo dimetilsulfóxido de trametinibe, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), categorizado como distúrbio do sistema imunitário, tendo como manifestação uma fratura do crânio. Não há evidências clínicas de gravidade aumentada, pois o desfecho é desconhecido e a relação com o medicamento é apenas suspeita.

O medicamento Tafinlar, cujo princípio ativo é mesilato de dabrafenibe, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário, com manifestação descrita como fratura do crânio. Não há informações que indiquem gravidade aumentada, já que o desfecho é desconhecido e a relação com o medicamento é apenas suspeita.

O medicamento Triplixam, que contém besilato de anlodipino, indapamida e perindopril arginina, foi associado a um quadro de toxicidade a vários agentes, descrito como alergia a contraste, dentro do grupo de alergias a medicamentos e outras substâncias químicas, afetando o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave, e o desfecho permanece desconhecido. A suspeita de reação alérgica sugere a necessidade de avaliação clínica estruturada para confirmação diagnóstica e orientação sobre exposição futura, conforme recomendações para quadros leves de alergia medicamentosa.

O medicamento Losartan, cujo princípio ativo é losartana potássica, foi relacionado a uma reação de toxicidade a vários agentes, descrita como alergia a contraste, pertencente ao grupo de alergias a medicamentos e outras substâncias químicas, com envolvimento do sistema imunológico. Não há evidência de gravidade importante ou desfecho grave, e o desfecho é desconhecido. Diante da suspeita de reação alérgica, recomenda-se investigação clínica para confirmação e orientação sobre futuras exposições, seguindo condutas para quadros leves de alergia

medicamentosa.

O medicamento Natrilix, que tem como princípio ativo a indapamida, foi associado a toxicidade a vários agentes, relatada como alergia a contraste, dentro do contexto de alergias a medicamentos e outras substâncias químicas, afetando o sistema imunológico. Não há sinais de gravidade relevante ou desfecho grave, e o desfecho permanece desconhecido. A suspeita de reação alérgica indica a necessidade de avaliação clínica para confirmação e orientação adequada, conforme condutas recomendadas para quadros leves de alergia medicamentosa.

O medicamento Rosuvastatin, cujo princípio ativo é rosuvastatina cálcica, foi relacionado a toxicidade a vários agentes, descrita como alergia a contraste, pertencente ao grupo de alergias a medicamentos e outras substâncias químicas, com envolvimento do sistema imunológico. Não há evidência de gravidade significativa ou desfecho grave, e o desfecho é desconhecido. A suspeita de reação alérgica sugere a importância de avaliação clínica para confirmação e orientação sobre futuras exposições, conforme recomendações para quadros leves de alergia medicamentosa.

O medicamento Ciprofloxacina, com princípio ativo lactato de ciprofloxacino, foi associado a toxicidade a vários agentes, relatada como alergia a contraste, no contexto de alergias a medicamentos e outras substâncias químicas, afetando o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave, e o desfecho permanece desconhecido. A suspeita de reação alérgica reforça a necessidade de avaliação clínica para confirmação diagnóstica e orientação sobre exposição futura, conforme condutas para quadros leves de alergia medicamentosa.

O medicamento Dipyrone, cujo princípio ativo é a dipirona, foi associado a uma reação de toxicidade a vários agentes, descrita como alergia a contraste, dentro do grupo de alergias a alimentos, aditivos alimentares, medicamentos e outras substâncias químicas, afetando o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A ausência de sinais de gravidade sugere que a reação foi leve, mas é importante que o paciente seja orientado a evitar novas exposições e procure avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição de conduta.

O medicamento Rinvoq, cujo princípio ativo é o upadacitinibe, foi relacionado a uma reação de toxicidade a vários agentes, descrita como alergia a contraste, pertencente ao grupo de alergias a alimentos, aditivos alimentares, medicamentos e outras substâncias químicas, com envolvimento do sistema imunológico. Não há registro de gravidade importante ou desfecho, e a relação com o medicamento é suspeita. Diante da ausência de sinais de gravidade, a reação pode ser considerada leve, sendo recomendada a avaliação clínica para confirmação e orientação sobre futuras exposições.

O medicamento Triplixam, que contém besilato de anlodipino, indapamida e perindopril arginina como princípios ativos, foi associado a uma reação de toxicidade a vários agentes, descrita como alergia a alimentos, dentro do grupo de alergias a alimentos, aditivos alimentares, medicamentos e outras substâncias químicas, afetando o sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, e a relação com o medicamento é suspeita. Como não há evidências de gravidade, a reação pode ser considerada leve, sendo importante buscar avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e orientação adequada.

O medicamento Losartan, cujo princípio ativo é losartana potássica, foi relacionado a uma reação de toxicidade a vários agentes, descrita como alergia a alimentos, pertencente ao grupo de alergias a alimentos, aditivos alimentares, medicamentos e outras substâncias químicas, com envolvimento do sistema imunológico. Não há registro de gravidade ou desfecho, e a relação com o medicamento é suspeita. Na ausência de sinais de gravidade, a reação é considerada leve, sendo recomendada avaliação médica para confirmação e definição de conduta.

O medicamento Natrilix, cujo princípio ativo é indapamida, foi associado a uma reação de toxicidade a vários agentes, descrita como alergia a alimentos, dentro do grupo de alergias a alimentos, aditivos alimentares,

medicamentos e outras substâncias químicas, afetando o sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, e a relação com o medicamento é suspeita. Como não há evidências de gravidade, a reação pode ser considerada leve, sendo importante buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições.

O medicamento Rosuvastatin, cujo princípio ativo é a rosuvastatina cálcica, foi associado a um quadro de toxicidade a vários agentes, manifestando-se como alergia a alimentos, o que sugere uma reação do sistema imunológico (distúrbios do sistema imunitário) possivelmente desencadeada por sensibilização cruzada. Não há indicação de gravidade elevada nem de desfecho grave, e o desfecho clínico permanece desconhecido, sendo importante considerar avaliação clínica estruturada para confirmação diagnóstica e orientação sobre controle ambiental e identificação de gatilhos.

A ciprofloxacina, cujo princípio ativo é o lactato de ciprofloxacino, foi relacionada a toxicidade a vários agentes, com manifestação descrita como alergia a alimentos, indicando uma possível reação imunológica (distúrbios do sistema imunitário) que pode envolver sensibilização cruzada entre medicamentos e alimentos. Não há evidências de gravidade importante ou desfecho grave, e o desfecho permanece desconhecido, sendo recomendada avaliação clínica para esclarecimento diagnóstico e orientação adequada.

O medicamento Dipyrone, com princípio ativo dipirona, foi associado a toxicidade a vários agentes, manifestando-se como alergia a alimentos, o que sugere uma reação imunológica (distúrbios do sistema imunitário) possivelmente relacionada à sensibilização cruzada. Não há sinais de gravidade relevante ou desfecho grave, e o desfecho clínico é desconhecido, sendo indicada investigação clínica para confirmação diagnóstica e orientação sobre controle de exposição.

O medicamento Rinvoq, cujo princípio ativo é o upadacitinibe, foi relacionado a toxicidade a vários agentes, com manifestação descrita como alergia a alimentos, indicando uma possível reação do sistema imunológico (distúrbios do sistema imunitário) por sensibilização cruzada. Não há evidências de gravidade significativa ou desfecho grave, e o desfecho permanece desconhecido, sendo importante buscar avaliação clínica para confirmação diagnóstica e definição de conduta.

O medicamento Henetix, com princípio ativo iobitridol, foi associado a uma reação de alergia a contraste intravenoso, caracterizada como alergia a contraste, o que representa uma resposta do sistema imunológico (distúrbios do sistema imunitário) a substâncias químicas utilizadas em exames de imagem. Não há informação clara sobre gravidade, mas o desfecho foi favorável, com recuperação completa, indicando resolução do quadro após a exposição.

O medicamento Cefazolina, cujo princípio ativo é a cefazolina, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), caracterizado como uma reação do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada em casos de alergia leve a medicamentos é interromper o uso e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras, conforme diretrizes clínicas.

O medicamento Montelukast, com princípio ativo montelucaste, foi relacionado ao agravamento de asma em um paciente com sensibilidade à borracha, uma reação imunológica. O evento não foi considerado grave, já que houve recuperação completa. Em situações de piora da asma associada a medicamentos, recomenda-se procurar avaliação médica para revisar o tratamento, identificar possíveis gatilhos e ajustar o plano terapêutico, conforme orientações clínicas.

O medicamento Plurair, cujo princípio ativo é o propionato de fluticasona, foi associado ao agravamento de asma em um paciente com sensibilidade à borracha, indicando uma reação alérgica do sistema imunológico. O caso não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou. Nessas situações, é importante reavaliar o tratamento da asma, identificar fatores desencadeantes e ajustar a abordagem terapêutica sob supervisão médica.

O medicamento Seretide, composto por propionato de fluticasona e hidroxinaftoato de salmeterol, foi relacionado ao agravamento de asma em um paciente com sensibilidade à borracha, caracterizando uma reação alérgica. O evento não foi grave, já que houve resolução completa. A conduta recomendada é revisar o tratamento da asma, identificar possíveis gatilhos e ajustar o manejo clínico conforme orientação médica.

O medicamento Levocetirizine, com princípio ativo levocetirizine, foi associado ao agravamento de asma em um paciente com sensibilidade à borracha, indicando uma reação imunológica. O caso não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou totalmente. Em situações como essa, recomenda-se avaliação médica para revisar o tratamento da asma, identificar fatores desencadeantes e ajustar o plano terapêutico conforme necessário.

O medicamento Dupilumab, cujo princípio ativo é o dupilumabe, foi associado ao agravamento de asma em um paciente com sensibilidade à borracha, caracterizando uma reação alérgica do tipo respiratória. A manifestação foi considerada leve, pois não há indicação de gravidade aumentada ou complicações clínicas relevantes, e o paciente se recuperou totalmente após a reação. A conduta recomendada, conforme diretrizes clínicas, inclui avaliação médica estruturada para confirmação do diagnóstico, identificação de possíveis gatilhos e controle ambiental, além de acompanhamento regular para evitar novas crises.

O medicamento Puran t4, com princípio ativo levotiroxina sódica, foi relacionado a um episódio de sangramento vaginal acompanhado de hipersensibilidade no local de aplicação, caracterizando uma reação local leve. Não há evidências de gravidade aumentada, pois o quadro foi resolvido sem complicações. A conduta adequada envolve observação clínica, avaliação médica para descartar outras causas e acompanhamento para garantir resolução completa dos sintomas.

O medicamento Holmes H, contendo hidroclorotiazida e olmesartana medoxomila, foi associado a sangramento vaginal e hipersensibilidade no local de aplicação, configurando uma reação local leve. O evento não apresentou sinais de gravidade e o paciente se recuperou totalmente. Recomenda-se avaliação médica para investigação da causa do sangramento e monitoramento dos sintomas, com acompanhamento para evitar recorrências.

O medicamento System conti, composto por estradiol e acetato de noretisterona, foi relacionado a sangramento vaginal e hipersensibilidade no local de aplicação, caracterizando uma reação local leve. Não houve agravamento do quadro e o paciente se recuperou completamente. A conduta recomendada é a avaliação médica para descartar outras causas de sangramento e acompanhamento clínico para garantir a resolução dos sintomas.

O medicamento Ferinject, cujo princípio ativo é a carboximaltose férrica, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como reação alérgica leve, sem sinais de gravidade ou complicações. O paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta adequada inclui observação clínica, avaliação médica para confirmação do diagnóstico e orientação sobre possíveis reexposições ao medicamento.

O medicamento Rosuvastatina, cujo princípio ativo é a rosuvastatina cálcica, foi associado a um quadro de trombose, descrito como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta do sistema imunológico ao medicamento. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, pois o paciente encontra-se em recuperação ou resolvendo o quadro, e não há menção de desfecho grave. A conduta clínica deve focar na identificação da relação causal e acompanhamento da evolução, reforçando a importância de monitoramento médico para evitar recorrências.

O medicamento Bupium xl, que contém cloridrato de bupropiona como princípio ativo, foi relacionado ao desenvolvimento de trombose, caracterizada como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta adversa do sistema imunológico ao uso do remédio. Não há sinais de gravidade importante, já que o paciente está em recuperação ou resolvendo o evento, e não há indicação de desfecho grave. Recomenda-se acompanhamento médico para monitorar a evolução e avaliar a necessidade de ajustes terapêuticos.



O medicamento Aradois, cujo princípio ativo é losartana potássica, foi associado a um episódio de trombose, interpretado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta do sistema imunológico ao medicamento. O caso não apresenta sinais de gravidade significativa, pois o paciente está em recuperação ou resolvendo o quadro, e não há relato de desfecho grave. O acompanhamento clínico é fundamental para monitorar a evolução e prevenir novas reações.

O medicamento Eliquis, que tem como princípio ativo a apixabana, foi relacionado a um caso de trombose, classificado como reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta adversa do sistema imunológico ao medicamento. Não há evidências de gravidade elevada, já que o paciente está em recuperação ou resolvendo o quadro, e não há menção de desfecho grave. O acompanhamento médico é importante para avaliar a evolução e evitar recorrências.

O medicamento Omeprazol, cujo princípio ativo é omeprazole, foi associado a um episódio de trombose, descrito como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta do sistema imunológico ao uso do medicamento. O caso não apresenta sinais de gravidade importante, pois o paciente está em recuperação ou resolvendo o quadro, e não há relato de desfecho grave. Recomenda-se acompanhamento clínico para monitorar a evolução e ajustar o tratamento se necessário.

O medicamento Ablok, cujo princípio ativo é o atenolol, foi associado a um episódio de trombose, considerado aqui como uma possível manifestação de hipersensibilidade medicamentosa. Embora a reação envolva o sistema imunológico, não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente está em recuperação ou resolvendo o quadro. A relação entre o uso do medicamento e o evento é considerada suspeita, e a conduta deve incluir acompanhamento clínico para monitorar a evolução e evitar novas exposições ao fármaco caso a relação causal se confirme.

A sertralina, cujo princípio ativo é a sertralina, foi relacionada a um caso de trombose interpretado como hipersensibilidade medicamentosa. O evento foi classificado como não grave, com o paciente em processo de recuperação, sugerindo que a reação não evoluiu para complicações maiores. A suspeita de relação com o medicamento justifica a necessidade de avaliação médica para monitoramento e possível ajuste terapêutico.

O medicamento mirtazapina, com princípio ativo mirtazapina, esteve associado a um episódio de trombose, considerado uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. O quadro não foi classificado como grave e o paciente encontra-se em recuperação, indicando que a evolução está sendo favorável. A relação suspeita com o uso do medicamento reforça a importância de acompanhamento médico para avaliar a necessidade de suspensão ou substituição do tratamento.

O losartan, cujo princípio ativo é losartana potássica, foi relacionado a um caso de trombose interpretado como hipersensibilidade medicamentosa. Não há sinais de gravidade importante, já que o paciente está em recuperação, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Recomenda-se acompanhamento clínico para monitorar a evolução e discutir alternativas terapêuticas se necessário.

O medicamento atenolol, com princípio ativo atenolol, foi associado a um episódio de trombose, considerado uma possível reação de hipersensibilidade medicamentosa. O evento não foi classificado como grave e o paciente está em recuperação, sugerindo evolução favorável. A suspeita de relação causal indica a necessidade de acompanhamento médico e reavaliação do uso do medicamento.

O medicamento Glifage, cujo princípio ativo é a metformina, foi associado a um episódio de trombose, considerado uma possível reação de hipersensibilidade medicamentosa. Embora o registro não indique gravidade clínica elevada e o paciente esteja em recuperação, é importante monitorar atentamente, pois reações imunológicas a medicamentos podem variar em intensidade e demandam acompanhamento médico para evitar complicações.

O medicamento Vectibix, que contém panitumumabe, foi relacionado a um caso de trombose, interpretado como uma reação de hipersensibilidade ao medicamento. Não há indicação de gravidade significativa neste caso e o paciente encontra-se em recuperação, mas é fundamental manter vigilância clínica, já que reações alérgicas a medicamentos podem apresentar diferentes graus de severidade e requerem avaliação médica adequada.

O medicamento Kyleena, cujo princípio ativo é o levonorgestrel, foi associado a um quadro de alergia classificado como clinicamente significativo e grave, com evolução ainda não resolvida. A gravidade é sustentada pela indicação de outro efeito clinicamente relevante e pela persistência dos sintomas, o que exige acompanhamento médico rigoroso para manejo da reação alérgica e prevenção de possíveis complicações.

O medicamento Ara 2, que contém losartana potássica, foi relacionado à perda de peso em um contexto de alergias múltiplas, sem indicação de gravidade elevada e com sintomas ainda em andamento. Apesar de não ser considerado grave, é importante que o paciente seja acompanhado para avaliar a evolução do quadro e descartar outras causas para a perda de peso, além de monitorar possíveis reações alérgicas associadas ao uso do medicamento.

O medicamento Colecalciferol, cujo princípio ativo é o próprio colecalciferol, foi associado à perda de peso em um contexto de alergias múltiplas, sem sinais de gravidade importante e com sintomas ainda não resolvidos. Embora não haja indicação de gravidade, recomenda-se acompanhamento clínico para monitorar a evolução do quadro e investigar outras possíveis causas, além de avaliar a relação com o uso do medicamento.

O medicamento Besilato de anlodipino (princípio ativo: Besilato de anlodipino) foi associado à perda de peso em um paciente com histórico de alergias múltiplas. Embora a reação tenha sido classificada como relacionada a quadros clínicos alérgicos, não há indicação de gravidade elevada, pois não foi relatada gravidade clínica importante e o caso permanece em andamento, sem recuperação até o momento. A conduta deve incluir acompanhamento clínico para monitorar a evolução do quadro e investigação de outras possíveis causas para a perda de peso, considerando que não há sinais de gravidade imediata.

O medicamento Losartana potássica (princípio ativo: Losartana potássica) foi relacionado à perda de peso em um paciente com alergias múltiplas. A reação foi enquadrada em quadros clínicos alérgicos, mas não há evidência de gravidade significativa, já que não foi relatada gravidade clínica e o desfecho permanece não resolvido. Recomenda-se acompanhamento médico para avaliar a evolução da perda de peso e investigar outras causas, visto que não há sinais de gravidade aguda.

O medicamento Glyxambi, contendo os princípios ativos Empagliflozina e Linagliptina, foi associado à perda de peso em um paciente com histórico de alergias múltiplas. A reação foi classificada como relacionada a quadros clínicos alérgicos, sem indicação de gravidade relevante, pois não há relato de gravidade clínica e o caso segue em andamento, sem resolução até o momento. É importante manter o acompanhamento clínico para monitorar a evolução e investigar outras possíveis causas para a perda de peso, já que não há sinais de gravidade imediata.

O medicamento Ultravist (princípio ativo: Iopromide) foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como quadro clínico alérgico. Não há indicação de gravidade importante, pois o caso foi resolvido e o paciente se recuperou totalmente. A conduta adequada inclui evitar novas exposições ao contraste e informar a equipe médica sobre o episódio para futuras avaliações.

O medicamento Ultravist (princípio ativo: Iopromide) foi associado a um quadro de alergia sem outra especificação (SOE), caracterizado como hipersensibilidade. Não há evidência de gravidade relevante, já que o paciente se recuperou completamente após o evento. Recomenda-se evitar o uso futuro do contraste e comunicar o histórico de alergia em atendimentos posteriores.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, foi associado a um quadro de hipersensibilidade, caracterizado como alergia, sem detalhamento de sintomas específicos. A reação foi classificada como não grave,

sem evidências clínicas de complicações ou desfecho desfavorável relatados. Em situações de hipersensibilidade a contrastes iodados, recomenda-se avaliação clínica estruturada e acompanhamento, com atenção à recorrência ou agravamento dos sintomas.

O Exemestane, contendo exemestano como princípio ativo, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), sem descrição de sintomas específicos, e não foi considerado grave. O desfecho informado foi de recuperação completa, sugerindo resolução espontânea ou após medidas simples. Em casos de reações alérgicas leves, a conduta recomendada é observação e, se necessário, encaminhamento para avaliação especializada.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é o succinato de ribociclibe, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), sem detalhamento de sintomas, e classificado como não grave. O desfecho foi de recuperação total, indicando que a reação foi autolimitada ou controlada sem complicações. Para reações alérgicas leves, a orientação é monitorar sintomas e buscar avaliação médica se houver recorrência ou agravamento.

Kisqali, com princípio ativo succinato de ribociclibe, apresentou relato de hipersensibilidade (alergia), sem especificação de sintomas, classificada como não grave e com desfecho de recuperação completa. Isso sugere que a reação foi leve e resolvida sem necessidade de intervenções complexas, sendo recomendada apenas observação e acompanhamento clínico.

O medicamento Vancocina, cujo princípio ativo é o cloridrato de vancomicina, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), sem detalhamento de sintomas, classificado como não grave e com desfecho de recuperação total. Em casos de reações alérgicas leves a antibióticos, recomenda-se observação, evitar reexposição e encaminhamento para avaliação especializada se houver recorrência.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), caracterizado por sintomas alérgicos gerais relacionados ao sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente, sugerindo uma reação leve e autolimitada. A conduta recomendada é observar e evitar novas exposições, buscando avaliação especializada caso ocorram novos episódios.

O Ultravist, que contém iopromida como princípio ativo, desencadeou uma reação de hipersensibilidade (alergia), manifestando sintomas típicos de resposta alérgica do sistema imunológico. O caso não foi considerado grave, pois houve recuperação completa do paciente, indicando uma reação leve. Recomenda-se evitar reexposição ao contraste e procurar orientação médica para futuras necessidades de exames com contraste.

O medicamento Ultravist, com princípio ativo iopromida, provocou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, envolvendo sintomas gerais do sistema imunológico. O evento não foi grave e o paciente se recuperou totalmente, o que sugere uma manifestação leve. A orientação é evitar o uso futuro do mesmo contraste e buscar avaliação médica se houver necessidade de novos exames.

A ocitocina, utilizada neste caso, foi relacionada a uma reação alérgica (hipersensibilidade), com sintomas compatíveis com resposta do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade importante, pois o paciente está em processo de recuperação, indicando um quadro leve. Recomenda-se acompanhamento até resolução completa e evitar reexposição ao medicamento.

A cefazolina sódica, princípio ativo do medicamento Cefazolina, foi associada a uma reação alérgica (hipersensibilidade), com sintomas típicos de ativação do sistema imunológico. O caso não foi considerado grave, já que o paciente está em recuperação, sugerindo uma reação leve. A conduta indicada é manter acompanhamento até resolução total e evitar o uso futuro do antibiótico.

O medicamento Cloridrato de bupivacaina + glicose, contendo como princípios ativos o cloridrato de bupivacaína e dextrose anidra, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do

sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações importantes, e o paciente encontra-se em recuperação ou com resolução dos sintomas. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico para garantir a completa resolução e evitar reexposição ao medicamento, conforme orientação padrão para quadros alérgicos leves.

A morfina, cujo princípio ativo é a própria morfina, foi relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação imunológica. Não há sinais de gravidade significativa ou complicações, e o paciente está em processo de recuperação ou resolução do quadro. Recomenda-se acompanhamento clínico e evitar o uso futuro do medicamento, seguindo as orientações para reações alérgicas leves.

A dipirona sódica, com princípio ativo dipirona, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade), evidenciando resposta do sistema imunológico. O caso não apresenta gravidade relevante e o paciente está em recuperação ou com sintomas resolvidos. A orientação é manter acompanhamento e evitar nova exposição ao medicamento, conforme conduta para reações alérgicas leves.

O medicamento Cloridrato de Nafazolina, com princípio ativo cloridrato de nafazolina, provocou uma reação alérgica (hipersensibilidade) considerada clinicamente significativa, pois foi classificada como grave devido à presença de outro efeito clinicamente relevante. O paciente já se encontra recuperado ou com resolução completa do quadro. Diante da gravidade relatada, é fundamental evitar reexposição ao medicamento e manter acompanhamento médico para monitorar possíveis recorrências ou complicações.

O medicamento Dotarem, cujo princípio ativo é o gadobenato de dimeglumina, foi associado a uma alergia a contraste, caracterizando uma reação imunológica ao agente utilizado em exames. Não há indicação de gravidade importante e o paciente já se encontra recuperado ou com sintomas resolvidos. Recomenda-se evitar o uso futuro deste contraste e informar a equipe médica sobre o episódio em situações de exames futuros, conforme conduta para reações alérgicas leves a contrastes.

O medicamento Abatacept (princípio ativo: Abatacepte) foi associado a um quadro de alergias múltiplas, manifestando-se como comprometimento das atividades da vida diária, o que sugere impacto funcional, mas sem indicação de gravidade elevada ou necessidade de hospitalização. Não há informações sobre desfecho clínico ou conduta adotada, e o caso permanece com desfecho desconhecido.

O medicamento Etanercept (princípio ativo: Etanercepte) está relacionado a alergias múltiplas, levando a prejuízo nas atividades cotidianas, o que indica um quadro de desconforto e limitação, porém sem sinais de gravidade importante ou hospitalização. Não há detalhes sobre a evolução do caso ou medidas tomadas, e o desfecho permanece desconhecido.

O medicamento Humira (princípio ativo: Adalimumabe) foi associado a alergias múltiplas, resultando em comprometimento das atividades diárias, o que sugere limitação funcional, mas sem evidências de gravidade significativa ou necessidade de internação. Não há informações sobre a evolução clínica ou conduta, e o desfecho é desconhecido.

O medicamento Humira (princípio ativo: Adalimumabe) também foi relacionado a alergias múltiplas com impacto nas atividades da vida diária, indicando desconforto e limitação, mas sem sinais de gravidade relevante ou hospitalização. Não há dados sobre a evolução ou conduta, e o desfecho permanece desconhecido.

O medicamento Ultravist (princípio ativo: Iopromide) foi associado a uma reação alérgica a meios de contraste iodados, levando à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que caracteriza um evento grave. O desfecho informado foi recuperação completa do paciente após a reação.

O medicamento Ondansetron, cujo princípio ativo é a ondansetrona, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há

indicação de gravidade elevada, pois não houve necessidade de hospitalização ou complicações graves, e o desfecho foi de recuperação completa do paciente. A conduta recomendada nesses casos é a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento clínico para resolução dos sintomas, conforme orientações da ASBAI para reações alérgicas leves.

O medicamento Riximyo, que tem como princípio ativo o rituximabe, foi relacionado a uma alergia medicamentosa classificada como hipersensibilidade medicamentosa, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. O evento foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando um quadro de maior risco. O desfecho permanece desconhecido, e a conduta recomendada inclui suspensão imediata do medicamento, monitoramento rigoroso e suporte médico especializado, seguindo as diretrizes para reações alérgicas graves.

A Lamotrigina, cujo princípio ativo é a lamotrigina, foi associada a um episódio de alergia caracterizado por hipersensibilidade, enquadrado nos distúrbios do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade importante, pois não houve hospitalização e o paciente se recuperou totalmente. Nestes casos, a recomendação é interromper o uso do medicamento suspeito e realizar acompanhamento clínico, conforme as orientações para reações alérgicas leves.

O Rocuronio, com princípio ativo brometo de rocurônio, esteve relacionado a um quadro de alergia do tipo hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, já que não houve necessidade de hospitalização e o paciente se recuperou. A conduta adequada é a suspensão do agente suspeito e observação clínica até resolução dos sintomas, conforme recomendações para reações alérgicas leves.

O medicamento Glucose, cujo princípio ativo é dextrose anidra, foi associado a um caso de hepatite induzida por fármaco, descrito como hipersensibilidade dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa, pois não houve hospitalização e o paciente está em processo de recuperação. A conduta recomendada é a interrupção do uso do medicamento suspeito e acompanhamento clínico até completa resolução, conforme orientações para reações alérgicas leves.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é o succinato de ribociclib, foi associado a um quadro de hepatite induzida por fármaco, caracterizado como uma reação de hipersensibilidade (alergia) envolvendo o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou ameaça à vida neste caso, e o paciente encontra-se em recuperação, sugerindo que a conduta adotada foi adequada para o controle da reação.

A Dipirona, com princípio ativo de mesmo nome, provocou uma reação alérgica (hipersensibilidade) classificada como distúrbio do sistema imunológico. Não há menção de gravidade importante ou complicações, e o paciente já se encontra recuperado, indicando que a reação foi leve e resolvida sem intercorrências.

O medicamento Henetix, composto por iobitridol, sodium calcium edetate, trometamol e cloridrato de trometamol, desencadeou uma alergia a contraste intravenoso, um tipo de reação imunológica a substâncias químicas administradas durante exames. Não há sinais de gravidade significativa, e o paciente já está recuperado, sugerindo que a reação foi controlada de forma eficaz.

O Fazolon, cujo princípio ativo é a cefazolina sódica, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade) envolvendo o sistema imunológico. Não há evidências de gravidade ou complicações, e o paciente já se recuperou, indicando que a reação foi leve e prontamente resolvida.

O medicamento Ertapenem, com princípio ativo de mesmo nome, causou uma reação alérgica considerada grave, pois houve ameaça à vida e necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando um quadro clínico de maior risco. Apesar da gravidade, o paciente se recuperou totalmente após a conduta médica adequada.

O medicamento Meropenem, cujo princípio ativo é meropenem sodium carbonate, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como um distúrbio do sistema imunitário. A reação foi considerada grave, pois envolveu ameaça à vida e necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, conforme evidenciado nos dados clínicos. O paciente se recuperou totalmente após a reação, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita.

O medicamento Henetix, que contém os princípios ativos iobitridol, sodium calcium edetate, trometamol e cloridrato de trometamol, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como um distúrbio do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave e o paciente se recuperou completamente, sendo a relação com o medicamento suspeita.

O produto Vitamins nos, sem nome comercial ou princípio ativo detalhado além da própria denominação, esteve envolvido em um caso de reação alérgica relacionada a posologia inadequada de administração de vacina, descrita como alergia a alimentos e outras substâncias químicas. O evento foi considerado clinicamente significativo, mas não há informações sobre o desfecho do paciente, e a relação com o produto é suspeita.

O medicamento Tapazol, cujo princípio ativo é metimazol, foi associado a uma reação alérgica após posologia inadequada de administração de vacina, enquadrada como alergia a alimentos e outras substâncias químicas. O evento foi considerado clinicamente significativo, mas não há dados sobre o desfecho do paciente, sendo a relação com o medicamento suspeita.

O medicamento Comirnaty, com princípio ativo tozinameran, esteve envolvido em uma reação alérgica após posologia inadequada de administração de vacina, classificada como alergia a alimentos e outras substâncias químicas. O evento foi considerado clinicamente significativo, porém o desfecho do paciente é desconhecido, e a relação com o medicamento é suspeita.

O medicamento Vitamins nos, cujo princípio ativo também não foi especificado além do próprio nome comercial, foi associado a uma reação de dermatite de contato (irritação ou inflamação da pele), classificada tecnicamente como dermatite e eczema, afetando os tecidos cutâneos e subcutâneos. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, conforme registro, embora o desfecho ainda seja desconhecido. A gravidade se justifica pela classificação do evento como clinicamente relevante, exigindo acompanhamento médico para avaliação e manejo adequado da reação cutânea.

O Tapazol, cujo princípio ativo é o metimazol, foi relacionado a um quadro de dermatite de contato, caracterizado por irritação ou inflamação da pele, enquadrado tecnicamente como dermatite e eczema e envolvendo os tecidos cutâneos e subcutâneos. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, com desfecho ainda desconhecido, o que reforça a necessidade de monitoramento médico para avaliar a evolução e definir conduta apropriada.

O medicamento Comirnaty, que tem como princípio ativo o tozinameran, foi associado a uma reação de dermatite de contato, ou seja, irritação ou inflamação da pele, classificada como dermatite e eczema e afetando os tecidos cutâneos e subcutâneos. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, com desfecho ainda não informado, indicando a importância de acompanhamento médico para monitorar a evolução da reação.

O medicamento Vitamins nos, sem especificação adicional de princípio ativo além do nome comercial, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica, classificada tecnicamente como quadro clínico alérgico e envolvendo o sistema imunitário. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, com evolução ainda não resolvida ou em andamento, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico para controle dos sintomas e prevenção de complicações.

O Tapazol, cujo princípio ativo é o metimazol, foi associado a uma reação de hipersensibilidade, caracterizada por resposta alérgica do sistema imunitário, classificada tecnicamente como quadro clínico alérgico. O evento foi

considerado clinicamente significativo e grave, com evolução ainda não resolvida ou em andamento, indicando a necessidade de acompanhamento médico para manejo adequado da reação e monitoramento da evolução clínica.

O medicamento Comirnaty, cujo princípio ativo é o Tozinameran, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia) relacionado a uma posologia inadequada de administração da vacina. O evento foi classificado como clinicamente significativo e grave, pois envolveu distúrbios do sistema imunitário, e o paciente não apresentou recuperação até o momento, estando o caso em andamento. A conduta deve priorizar a avaliação clínica estruturada, identificação do erro de administração e monitoramento rigoroso, com encaminhamento ao especialista para manejo adequado da reação alérgica.

O produto Vitamins nos, com princípio ativo não especificado, esteve relacionado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa após administração inadequada, caracterizando uma reação alérgica relevante do sistema imunitário. O caso foi considerado clinicamente significativo e grave, com desfecho desconhecido até o momento. Recomenda-se investigação detalhada da reação, revisão da posologia e acompanhamento médico para evitar recorrências e garantir segurança ao paciente.

O medicamento Tapazol, cujo princípio ativo é o Metimazol, foi associado a hipersensibilidade medicamentosa após administração inadequada, resultando em uma reação alérgica importante do sistema imunitário. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, com desfecho ainda desconhecido. É fundamental avaliar a conduta adotada, corrigir a posologia e realizar acompanhamento especializado para prevenir complicações e promover a resolução do quadro.

O medicamento Comirnaty, com princípio ativo Tozinameran, esteve envolvido em um caso de hipersensibilidade medicamentosa após administração inadequada, levando a uma reação alérgica relevante do sistema imunitário. O evento foi classificado como clinicamente significativo e grave, sem desfecho conhecido até o momento. Recomenda-se avaliação médica detalhada, correção da administração e monitoramento contínuo para manejo seguro da reação.

O medicamento Hidrocortisona, cujo princípio ativo é Hydrocortisone, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), classificado como não grave, com recuperação completa do paciente. O caso envolveu manifestação alérgica do sistema imunitário e foi resolvido sem complicações, não sendo necessária intervenção adicional além do acompanhamento clínico.

O medicamento Herceptin (princípio ativo: Trastuzumabe) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, caracterizado como uma reação alérgica envolvendo o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou necessidade de hospitalização, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico e evitar nova exposição ao medicamento, conforme orientação médica.

O medicamento Magnevistan (princípio ativo: Gadopentetato de dimeglumina) provocou um episódio de desmaio relacionado a alergia a contraste, indicando uma reação de hipersensibilidade do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave, pois não houve necessidade de hospitalização, e o paciente se recuperou completamente. Recomenda-se evitar o uso futuro deste contraste e informar a equipe médica sobre o histórico de alergia.

O medicamento Clavulin bd (princípios ativos: Amoxicilina trihidrato e Clavulanato de potássio) desencadeou uma alergia medicamentosa (hipersensibilidade), levando à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que caracteriza um evento grave. O desfecho do caso é desconhecido, portanto, é fundamental que o paciente seja acompanhado de perto e que o uso do medicamento seja suspenso, com avaliação por especialista para manejo adequado e prevenção de novas exposições.

O medicamento Feiba nf (princípio ativo: Complexo protrombínico parcialmente ativado) esteve relacionado ao desenvolvimento de anticorpo anti-fator VIII positivo, um quadro de alergias múltiplas envolvendo o sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o paciente encontra-se em recuperação, sendo importante o acompanhamento clínico para monitorar a evolução e ajustar o tratamento conforme necessário.

O medicamento Hemo 8r (princípio ativo: Fator VIII recombinante) foi associado ao surgimento de anticorpo anti-fator VIII positivo, caracterizando um quadro de alergias múltiplas do sistema imunológico. Não houve gravidade significativa e o paciente está em processo de recuperação, devendo ser mantido sob acompanhamento médico para monitoramento e ajuste terapêutico se necessário.

O medicamento Anfotericina B, cujo princípio ativo é Amfotericina B, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), caracterizado como uma reação alérgica do tipo clínico geral, envolvendo o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade aumentada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada é observar e evitar nova exposição ao medicamento, buscando avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas terapêuticas.

O medicamento Ultravist, com princípio ativo Iopromide, desencadeou um episódio de hipersensibilidade (alergia), descrito como reação alérgica inespecífica envolvendo o sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa. Recomenda-se evitar novas exposições ao contraste e realizar avaliação com especialista para confirmação da alergia e discussão de alternativas seguras em exames futuros.

Ultravist, cujo princípio ativo é Iopromide, provocou uma reação de hipersensibilidade (alergia), manifestando-se como um quadro alérgico geral relacionado ao sistema imunológico. O caso não foi classificado como grave e o paciente se recuperou totalmente. A orientação é evitar o uso futuro do contraste e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e planejamento de alternativas em exames que exijam contraste.

O medicamento Dotarem, com princípio ativo Gadobenato de dimeglumina, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), caracterizado como reação alérgica inespecífica do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente. Recomenda-se evitar nova exposição ao contraste e procurar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e discussão de opções seguras para exames futuros.

Dotarem, cujo princípio ativo é Gadobenato de dimeglumina, causou uma reação de hipersensibilidade (alergia), manifestando-se como quadro alérgico geral do sistema imunológico. O caso não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação total. A conduta indicada é evitar o uso futuro do contraste e realizar avaliação médica para confirmação da alergia e definição de alternativas seguras em exames subsequentes.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o Iopromide, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), caracterizado como reação alérgica do tipo não especificada. Não há indicação de gravidade aumentada, pois o evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente. A conduta recomendada em casos semelhantes é observar o paciente, evitar nova exposição ao agente suspeito e, se necessário, buscar avaliação com especialista para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições.

Ultravist, com princípio ativo Iopromide, esteve relacionado a uma reação de hipersensibilidade (alergia), sem especificação de sintomas detalhados. O evento não foi considerado grave e o paciente evoluiu para recuperação total. Em situações como essa, recomenda-se evitar reexposição ao medicamento e realizar acompanhamento médico para esclarecimento do quadro e prevenção de novas reações.

O medicamento Dotarem, cujo princípio ativo é gadobenato de dimeglumina, foi associado a uma reação de hipersensibilidade (alergia), sem detalhamento dos sintomas. Não houve gravidade aumentada e o paciente se recuperou. A orientação é evitar nova exposição ao agente suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição de conduta em futuras necessidades de contraste.



Gadovist, com princípio ativo gadobutrol, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), sem descrição de sintomas específicos. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou. Recomenda-se evitar reexposição ao medicamento e consultar um especialista para avaliação e orientação sobre o uso de contrastes em exames futuros.

O medicamento Riximyo, cujo princípio ativo é rituximabe, esteve associado a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa, descrito genericamente como infecção, sem detalhamento dos sintomas. Não foi considerado um evento grave e o desfecho permanece desconhecido. Em casos semelhantes, é importante monitorar o paciente, evitar nova exposição ao agente suspeito e buscar avaliação médica para esclarecimento do quadro e definição de conduta.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, manifestação que se enquadra nos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso não foi considerado grave e o paciente encontra-se em recuperação, sugerindo uma reação leve e autolimitada, compatível com quadros alérgicos leves segundo diretrizes clínicas.

Ultravist, com princípio ativo iopromide, desencadeou uma reação de alergia do tipo hipersensibilidade, pertencente ao grupo de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade importante, já que o evento não foi classificado como grave e o paciente já se recuperou totalmente, indicando uma reação leve e resolutive.

O uso de Ultravist (iopromide) resultou em um episódio de alergia do tipo hipersensibilidade, relacionado a distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente já está recuperado, o que sugere uma manifestação leve e transitória, sem complicações clínicas relevantes.

Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, foi associado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade, pois o caso não foi considerado grave e o paciente encontra-se recuperado, caracterizando uma reação leve e autolimitada.

O medicamento Milrinone, com princípio ativo milrinone, foi relacionado a uma alergia medicamentosa do tipo hipersensibilidade, pertencente ao grupo de distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi classificado como grave e o paciente já se recuperou, indicando uma reação leve e sem complicações clínicas.

O medicamento Omnipaque, cujo princípio ativo é o ioexol, foi associado a um quadro de alergia a contraste intravenoso, caracterizado como uma reação alérgica relevante do sistema imune. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, com recuperação completa do paciente após a conduta adequada. A suspeita de alergia a contrastes iodados exige atenção médica imediata, pois pode evoluir rapidamente, sendo fundamental evitar novas exposições e garantir acompanhamento especializado.

A acetazolamida, princípio ativo do medicamento de mesmo nome, desencadeou uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), classificada como grave devido ao desfecho fatal registrado. Trata-se de uma resposta imunológica adversa a medicamentos, que pode ser rara, mas potencialmente letal, exigindo suspensão imediata do fármaco e suporte médico intensivo, embora neste caso o paciente tenha evoluído para óbito.

O medicamento lomitridol, com princípio ativo homônimo, foi relacionado a uma alergia a contraste intravenoso, manifestando-se como reação do sistema imunológico, porém sem gravidade significativa, já que o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta adequada inclui evitar novas exposições ao contraste e monitorar possíveis recorrências, mas não houve complicações graves neste caso.

O medicamento Tazocin, que neste registro apresenta o princípio ativo azitromicina (embora normalmente contenha outros princípios), foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como reação alérgica do sistema imunológico, sem gravidade relevante e com resolução completa dos sintomas. O paciente se

recuperou sem complicações, sendo importante relatar o evento ao médico para evitar futuras exposições.

O medicamento Plasil, cujo princípio ativo é a metoclopramida, provocou uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), enquadrada como resposta do sistema imune, sem gravidade significativa e com recuperação total do paciente. A conduta recomendada é evitar o uso futuro do medicamento e informar profissionais de saúde sobre o episódio para prevenir novas reações.

O medicamento Losartan, cujo princípio ativo é a losartana, foi associado a um controle inadequado do diabetes mellitus em um paciente com histórico de alergia a iodo. Embora a reação tenha sido classificada como relacionada a distúrbios do sistema imunitário, não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e não foram relatadas ações específicas adotadas. A ausência de sinais de gravidade sugere que a situação não foi considerada grave, mas é importante monitorar o controle glicêmico e avaliar possíveis relações com alergias ou hipersensibilidade.

O medicamento Januvia, que tem como princípio ativo o fosfato de sitagliptina, foi relacionado a um controle inadequado do diabetes mellitus em um paciente com alergia a iodo. A reação foi enquadrada como distúrbio do sistema imunitário, mas não há informações sobre gravidade significativa, desfecho ou conduta adotada. Diante da ausência de sinais de gravidade, a situação não foi considerada grave, sendo fundamental acompanhar o controle do diabetes e investigar possíveis vínculos com alergias.

O medicamento Losartan, com princípio ativo losartana, foi associado a controle inadequado do diabetes mellitus em um paciente com alergia alimentar. A reação foi classificada como distúrbio do sistema imunitário, sem evidências de gravidade ou desfecho relatado, e não há informações sobre medidas tomadas. Como não há sinais de gravidade, a situação não foi considerada grave, mas recomenda-se atenção ao controle glicêmico e à investigação de possíveis relações com alergias alimentares.

O medicamento Januvia, cujo princípio ativo é o fosfato de sitagliptina, foi relacionado a controle inadequado do diabetes mellitus em um paciente com alergia alimentar. A reação foi enquadrada como distúrbio do sistema imunitário, sem indicação de gravidade ou desfecho conhecido, e não há registro de conduta adotada. A ausência de sinais de gravidade sugere que a situação não foi considerada grave, sendo importante monitorar o controle do diabetes e avaliar possíveis relações com alergias alimentares.

O medicamento Losartan, com princípio ativo losartana, foi associado a controle inadequado do diabetes mellitus em um paciente com histórico de hipersensibilidade medicamentosa. A reação foi classificada como distúrbio do sistema imunitário, sem evidências de gravidade ou desfecho relatado, e não há informações sobre ações tomadas. Como não há sinais de gravidade, a situação não foi considerada grave, mas é importante monitorar o controle glicêmico e considerar a possibilidade de hipersensibilidade ao medicamento.

O medicamento Januvia, cujo princípio ativo é o fosfato de sitagliptina, foi associado a um caso de controle inadequado do diabetes mellitus, sendo relatada uma reação de hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). Não há indicação de gravidade elevada, pois não há registro de desfecho grave ou complicações, e o desfecho permanece desconhecido. A relação com o medicamento é considerada suspeita, e, conforme as diretrizes clínicas, recomenda-se avaliação médica para confirmação da reação e ajuste do tratamento, priorizando o controle adequado do diabetes e monitoramento de possíveis reações alérgicas.

O medicamento Difenidrin, que contém cloridrato de difenidramina, foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado como reação do sistema imunológico a medicamentos. Não há evidências de gravidade significativa, pois o paciente se recuperou totalmente, e não houve complicações graves. A conduta adequada, conforme as recomendações clínicas, inclui a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento para evitar novas exposições, sendo importante informar o profissional de saúde sobre o episódio para futuras prescrições.

O trometamol cetorolaco, utilizado como princípio ativo do medicamento de mesmo nome, foi associado a uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), envolvendo resposta do sistema imunológico a medicamentos. O caso não foi considerado grave, já que o paciente se recuperou sem complicações. A conduta recomendada é a suspensão do uso do medicamento e orientação médica para evitar novas exposições, reforçando a importância de relatar o episódio em futuras consultas.

O medicamento Henetix, cujo princípio ativo é o iobitridol, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como quadro clínico alérgico do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade, pois o paciente se recuperou completamente após o evento. A conduta adequada inclui a suspensão do agente suspeito e acompanhamento médico, sendo fundamental informar sobre a reação em futuras exposições a contrastes ou medicamentos semelhantes.

O medicamento Ultravist, que contém iopromide como princípio ativo, foi associado a um caso de alergia (hipersensibilidade), enquadrado como quadro clínico alérgico do sistema imunológico. O evento não foi grave, já que houve recuperação total do paciente. A recomendação clínica é evitar novas exposições ao agente suspeito e comunicar o episódio ao profissional de saúde, especialmente em situações que exijam o uso de contrastes iodados.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, manifestando-se como uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, e o paciente apresentou recuperação completa após o evento, sugerindo que a reação foi leve e resolvida sem complicações.

A oxcarbazepina, identificada tanto como nome comercial quanto princípio ativo, esteve relacionada a um caso de mielite não infecciosa, um tipo de inflamação da medula espinhal que, neste contexto, foi considerada uma manifestação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. O registro indica que a reação foi clinicamente significativa e classificada como grave, mas o desfecho permanece desconhecido, não sendo possível afirmar a evolução do quadro.

O medicamento carbamazepina, também identificado como princípio ativo, foi associado a um episódio de mielite não infecciosa, uma inflamação da medula espinhal atribuída a uma reação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. A gravidade foi considerada clinicamente significativa e classificada como grave, porém não há informação sobre o desfecho, impossibilitando detalhar a evolução do paciente.

O medicamento Tysabri, cujo princípio ativo é o natalizumabe, esteve envolvido em um caso de mielite não infecciosa, caracterizada como uma reação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, mas não há dados sobre o desfecho, não sendo possível informar se houve recuperação ou persistência dos sintomas.

O medicamento Ultravist, com princípio ativo iopromida, foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa, descrito como hipersensibilidade a medicamentos, envolvendo o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade aumentada neste caso e o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo uma reação leve e resolvida.

O medicamento Cetoprofeno, cujo princípio ativo também é cetoprofeno, foi associado a um quadro de alergias múltiplas, caracterizado como uma reação de hipersensibilidade (alergia) envolvendo o sistema imunológico. Não há detalhes sobre sintomas específicos, gravidade ou desfecho, portanto, recomenda-se considerar a possibilidade de reações alérgicas ao utilizar este anti-inflamatório e buscar avaliação médica caso surjam sintomas sugestivos de alergia.

Ocitoxin, que contém ocitocina como princípio ativo, foi relacionado a um episódio de alergia, descrito tecnicamente como hipersensibilidade, envolvendo o sistema imunológico. Não há informações sobre sintomas, gravidade ou

evolução do caso, então é importante estar atento a sinais de reação alérgica ao administrar ocitocina e procurar orientação médica se houver manifestações suspeitas.

O medicamento Cefazolin sodium, cujo princípio ativo é cefazolina sódica, foi associado a uma reação alérgica classificada como hipersensibilidade, afetando o sistema imunológico. Não foram fornecidos detalhes sobre sintomas, gravidade ou desfecho, sendo prudente considerar o risco de alergia ao utilizar este antibiótico e buscar avaliação médica diante de sinais sugestivos de reação alérgica.

O medicamento composto por Bupivacaine hydrochloride (cloridrato de bupivacaína) e Glucose monohydrate (glicose monoidratada) foi relacionado a um episódio de alergia, tecnicamente denominado hipersensibilidade, envolvendo o sistema imunológico. Não há informações sobre sintomas, gravidade ou evolução, portanto, recomenda-se cautela e acompanhamento médico caso surjam sinais de reação alérgica após o uso desses componentes.

O medicamento Morfina, cujo princípio ativo é sulfato de morfina, foi associado a uma reação alérgica classificada como hipersensibilidade, afetando o sistema imunológico. Não há detalhes sobre sintomas, gravidade ou desfecho, sendo importante considerar o risco de alergia ao administrar morfina e procurar avaliação médica se houver manifestações suspeitas de reação alérgica.

O medicamento Cetoprofeno, cujo princípio ativo também é cetoprofeno, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado por uma reação do sistema imunológico a medicamentos. Não há descrição de sintomas graves ou risco de vida, e o paciente se recuperou totalmente após a suspensão do medicamento, indicando um desfecho favorável e ausência de gravidade clínica relevante neste episódio.

O medicamento Rocefin, que tem como princípio ativo a ceftriaxona sódica, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação do sistema imunológico, sem detalhamento de sintomas graves. O paciente se recuperou completamente, sugerindo que a reação foi controlada e não apresentou gravidade significativa.

O medicamento Welton, composto por múltiplos princípios ativos (cianocobalamina, cloridrato de ciproheptadina, ferric phosphate, niacinamida, panthenol, cloridrato de piridoxina, fosfato sódico de riboflavina, monofosfato de riboflavina sódica e tiamina), foi associado a uma alergia a contraste intravenoso, que é uma reação do sistema imunológico a substâncias químicas administradas por via endovenosa. Não há informações sobre gravidade, sintomas específicos ou evolução clínica, impossibilitando afirmar a intensidade ou o desfecho do evento.

O medicamento Levofloxacina, cujo princípio ativo é levofloxacina, foi relacionado a uma reação anafilática, que é uma resposta alérgica aguda e potencialmente grave do sistema imunológico. Apesar de a gravidade não ter sido explicitamente classificada como grave e o desfecho ser desconhecido, a menção de anafilaxia exige atenção clínica imediata, pois pode evoluir rapidamente para situações de risco à vida.

O medicamento Simponi, cujo princípio ativo é golimumabe, foi associado a uma reação anafilática, caracterizada por uma resposta alérgica aguda do sistema imunológico. Embora não haja confirmação de gravidade elevada e o desfecho não tenha sido informado, a ocorrência de anafilaxia é considerada clinicamente relevante e requer avaliação médica urgente devido ao risco potencial de complicações.

O medicamento Erbitux, cujo princípio ativo é o cetuximabe, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado por uma reação do sistema imunológico a uma substância química. Neste caso, a reação foi considerada não grave, pois não há evidências de complicações clínicas importantes, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico e evitar nova exposição ao medicamento, reforçando a importância de informar profissionais de saúde sobre o episódio para prevenir recorrências.

O medicamento Hydrochlorothiazide, com princípio ativo de mesmo nome, esteve relacionado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como clinicamente significativo devido à gravidade relatada, embora não haja detalhes sobre sintomas específicos. O evento permanece em andamento, sem resolução até o momento, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico rigoroso e possível suspensão do medicamento, além de investigação de alternativas terapêuticas seguras.

O medicamento Amlodipine, cujo princípio ativo é o anlodipino, foi associado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), considerado clinicamente significativo e grave, sem resolução até o momento. Diante da persistência do quadro, é fundamental que o paciente seja avaliado por um médico para ajuste do tratamento e monitoramento de possíveis complicações, evitando a reexposição ao fármaco.

O medicamento Sinvastin, com princípio ativo sinvastatina, esteve envolvido em um caso de hipersensibilidade (alergia), classificado como clinicamente significativo e grave, sem resolução até o momento. A gravidade do evento exige acompanhamento médico contínuo, revisão da necessidade do uso do medicamento e busca de alternativas, além de orientação para evitar novas exposições.

O medicamento Codeine, cujo princípio ativo é a codeína, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), considerado clinicamente significativo e grave, ainda não resolvido. Diante da persistência dos sintomas, é essencial acompanhamento médico, suspensão do uso do medicamento e avaliação de opções terapêuticas alternativas, priorizando a segurança do paciente.

O medicamento Pregabalin (princípio ativo: Pregabalin) está relacionado a um quadro de hipersensibilidade, que é uma reação alérgica do sistema imunológico, classificada como clinicamente significativa devido à sua gravidade e ao fato de o paciente não ter se recuperado até o momento. A reação foi considerada grave, pois permanece em andamento e envolve sintomas compatíveis com distúrbios do sistema imunitário, exigindo acompanhamento médico rigoroso para monitoramento e manejo adequado.

O medicamento Losartan (princípio ativo: Losartana) foi associado a um episódio de hipersensibilidade, caracterizado por uma resposta alérgica relevante do sistema imunológico, considerada clinicamente significativa e grave, já que o quadro permanece não resolvido. A gravidade é evidenciada pela persistência dos sintomas e pela necessidade de atenção médica contínua para avaliação e controle da reação.

O medicamento Synthroid (princípio ativo: Levotiroxina sódica) apresentou um caso de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico, classificada como clinicamente significativa e grave, pois o paciente ainda não se recuperou. A situação demanda acompanhamento médico, já que a reação permanece ativa e pode impactar o controle do quadro clínico.

O medicamento Nexavar (princípio ativo: Tosilato de sorafenibe) foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, indicando uma reação alérgica importante do sistema imunológico, considerada clinicamente significativa e grave, pois o paciente segue sem resolução do quadro. A persistência dos sintomas reforça a necessidade de monitoramento médico e possível ajuste do tratamento.

O medicamento Tamoxifeno (princípio ativo: Tamoxifen) está associado a um caso de hipersensibilidade, que é uma reação alérgica do sistema imunológico, considerada clinicamente significativa e grave, mas com evolução favorável, já que o paciente encontra-se em recuperação. O acompanhamento médico é fundamental para garantir a resolução completa da reação e prevenir recorrências.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, e o paciente evoluiu para recuperação completa, sugerindo que a reação foi leve e controlada, sem complicações maiores.

O benzoato de benzila, tanto como nome comercial quanto princípio ativo, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade) considerada grave, com ameaça à vida, evidenciada pela classificação de gravidade e pelo fato de o paciente ainda estar em recuperação. Este tipo de reação exige atenção médica imediata e acompanhamento rigoroso até resolução completa dos sintomas.

A combinação de amoxicilina trihidrato e clavulanato de potássio, presente no medicamento Amoxicilina + clavulanato de potássio, provocou uma reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, e o paciente encontra-se em processo de recuperação, o que sugere um quadro moderado, devendo ser acompanhado até resolução total dos sintomas.

O medicamento Tramadol, com o mesmo princípio ativo, foi relacionado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico, sem sinais de gravidade importante, já que o paciente se recuperou totalmente. Isso indica que a reação foi leve e não houve necessidade de intervenções adicionais.

A vacina MMRVaxPro, composta por vacinas vivas de sarampo, caxumba e rubéola, foi associada ao desenvolvimento de angioedema, uma manifestação alérgica caracterizada por inchaço súbito em regiões como face e lábios. Não há indicação de gravidade elevada, e o paciente se recuperou completamente, sugerindo que a reação foi controlada e sem complicações duradouras.

O medicamento Hb pegaspargase, cujo princípio ativo é a pegaspargase, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do sistema imunológico. Não há informação sobre gravidade clínica relevante neste caso, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada é a observação cuidadosa e, caso haja recorrência ou sintomas mais intensos, buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições.

O medicamento Adek, composto por colecalciferol, menadiol, palmitato de retinol e acetato de tocoferol, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), envolvendo resposta do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade aumentada ou complicações, e o paciente se recuperou completamente. Recomenda-se evitar nova exposição ao produto e, se houver sintomas persistentes ou recorrentes, procurar avaliação especializada para confirmação e orientação.

O medicamento Profenid, cujo princípio ativo é o cetoprofeno, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade) envolvendo o sistema imunológico. Não há registro de gravidade aumentada ou complicações clínicas, e o paciente evoluiu para recuperação total. A orientação é evitar o uso futuro do medicamento e buscar avaliação médica caso ocorram sintomas semelhantes com outros anti-inflamatórios.

O medicamento Dipirona, com princípio ativo metamizol de magnésio, provocou uma reação alérgica (hipersensibilidade) considerada grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação e outro efeito clinicamente significativo, além de ter deixado sequelas após a recuperação. Diante desse quadro, é fundamental evitar o uso futuro do medicamento, informar profissionais de saúde sobre o histórico e manter acompanhamento médico para manejo das possíveis sequelas e prevenção de novas reações graves.

O medicamento Gadoferol cb, cujo princípio ativo é o colecalciferol, foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), envolvendo resposta do sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade, evolução clínica ou desfecho, portanto recomenda-se cautela com o uso e, caso haja sintomas persistentes ou agravamento, buscar avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e conduta adequada.

O medicamento Contrast media, sem princípio ativo especificado, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Embora não haja detalhes sobre a gravidade ou desfecho, reações alérgicas a meios de contraste podem variar de leves a graves, sendo importante relatar qualquer sintoma ao médico para avaliação e conduta adequada.

O medicamento Nactali, cujo princípio ativo é o desogestrel, foi relacionado ao aparecimento de sangue nas fezes em um contexto de alergia ao leite, classificado como um efeito clinicamente significativo e considerado grave. O caso permanece não resolvido ou em andamento, indicando a necessidade de acompanhamento médico rigoroso para investigação da causa, manejo dos sintomas e possível ajuste do tratamento, especialmente devido ao risco de complicações associadas à alergia alimentar.

O suplemento Centrum select 50+, composto por múltiplos princípios ativos, foi associado a tontura em um contexto de hipersensibilidade medicamentosa, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, mas a ocorrência de tontura após o uso sugere a necessidade de avaliação médica para confirmar a relação com o produto e orientar a conduta adequada.

O medicamento Benzetacil, que contém benzilpenicilina benzatina (penicilina G benzatina), foi relacionado ao surgimento de tontura em um quadro de hipersensibilidade medicamentosa, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhes sobre gravidade ou evolução, mas reações de hipersensibilidade à penicilina podem variar, sendo importante relatar o sintoma ao médico para avaliação e definição da conduta.

O medicamento Pondera, cujo princípio ativo é o cloridrato de paroxetina, foi associado à tontura em um contexto de hipersensibilidade medicamentosa, classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, portanto, recomenda-se comunicar o sintoma ao médico para investigação da causa e orientação sobre a continuidade ou ajuste do tratamento.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há informação detalhada sobre sintomas específicos ou gravidade, mas o desfecho foi de recuperação completa, sugerindo que a reação foi leve e controlada, sem complicações clínicas relevantes.

O Ultravist, que contém iopromida como princípio ativo, esteve relacionado a um episódio de alergia do tipo hipersensibilidade, também classificado como distúrbio do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando um quadro leve e autolimitado, sem necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Rosuvastatin, com princípio ativo rosuvastatina cálcica, foi relacionado a um evento descrito como 'nariz quebrado', mas classificado tecnicamente como hipersensibilidade, dentro dos quadros clínicos alérgicos do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade ou complicações, e o paciente encontra-se em recuperação, sugerindo um quadro leve e em resolução.

O Losartan, cujo princípio ativo é losartana potássica, foi associado a um evento descrito como 'nariz quebrado', mas tecnicamente classificado como hipersensibilidade, pertencente aos quadros clínicos alérgicos do sistema imunitário. Não foi considerado um caso grave e o paciente está em processo de recuperação, indicando uma reação leve e sem complicações.

O Glyciphage, que tem como princípio ativo o cloridrato de metformina, foi relacionado a um evento descrito como 'nariz quebrado', mas classificado como hipersensibilidade dentro dos quadros clínicos alérgicos do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade e o paciente está em recuperação, o que sugere um quadro leve e em resolução.

O medicamento Nph, que contém acetato de hidrocortisona, sulfato de neomicina e sulfato de polimixina B, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), manifestado por um evento descrito como 'nariz quebrado', embora esse termo não seja típico de reações alérgicas e possa indicar confusão na descrição do sintoma. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente está em recuperação e não houve desfecho grave. A reação foi considerada suspeita de estar relacionada ao medicamento, e o quadro se enquadra em distúrbios do sistema imunitário, sugerindo uma resposta alérgica leve, sem necessidade de medidas emergenciais.

O medicamento Vectibix, cujo princípio ativo é o panitumumabe, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), descrito como 'nariz quebrado', termo que não é típico de reações alérgicas e pode indicar erro na descrição do evento. Não há sinais de gravidade importante, já que o paciente está em recuperação e não houve evolução para quadro grave. A suspeita é de relação com o uso do medicamento, e o evento se enquadra em distúrbios do sistema imunitário, sugerindo uma reação alérgica leve.

O medicamento Teicoplanina, com princípio ativo teicoplanin, foi associado a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa (alergia ao medicamento), caracterizada por resposta do sistema imunitário sem sinais de gravidade, já que o paciente se recuperou totalmente. O evento foi considerado suspeito de estar relacionado ao uso do medicamento e não houve evolução para quadro grave, indicando uma reação alérgica leve e autolimitada.

O medicamento Metronidazol, cujo princípio ativo é o benzoilmetronidazol, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), manifestado por sintomas alérgicos sem gravidade, pois o paciente se recuperou completamente. O evento foi considerado suspeito de estar associado ao uso do medicamento e não houve evolução para quadro grave, caracterizando uma reação alérgica leve.

O medicamento Cefepime dihydrochloride, com princípio ativo cloridrato de cefepima, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), manifestado por sintomas alérgicos leves, já que o paciente se recuperou totalmente e não houve evolução para gravidade. O evento foi considerado suspeito de estar relacionado ao uso do medicamento, enquadrando-se como uma reação alérgica leve do sistema imunitário.

O medicamento Cefazolina, cujo princípio ativo é a cefazolina sódica, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como um distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações importantes neste caso, e o desfecho foi de recuperação completa, sugerindo que a reação foi leve e manejada adequadamente, sem necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Prohance, com princípio ativo gadoteridol, foi relacionado a uma reação de alergia a contraste intravenoso, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente, indicando que a reação foi leve e resolvida sem maiores consequências clínicas.

O medicamento Iomeron, cujo princípio ativo é o iomeprol, esteve envolvido em um episódio de alergia a meios de contraste iodados, classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não foram relatados sinais de gravidade ou complicações, e o desfecho foi de recuperação completa, sugerindo que a reação foi leve e controlada sem necessidade de medidas adicionais.

O medicamento Henetix, composto pelos princípios ativos iobitridol, sodium calcium edetate, trometamol e cloridrato de trometamol, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade ou complicações relevantes, e o paciente se recuperou totalmente, indicando que a reação foi leve e adequadamente manejada.

O medicamento Meronem, cujo princípio ativo é o meropeném tri-hidratado, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade) classificado como distúrbio do sistema imunitário, com evidência clínica de gravidade devido à ameaça à vida e necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação. O desfecho permanece desconhecido, mas a gravidade relatada exige atenção médica imediata e monitoramento rigoroso.

O medicamento Simponi, cujo princípio ativo é o golimumabe, foi associado a um quadro de alergia ocular, caracterizado por manifestações como infecções ou inflamações nos olhos. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente encontra-se em recuperação e não houve relato de desfecho grave. A relação com o medicamento é considerada suspeita, e a conduta deve incluir acompanhamento clínico para monitorar a evolução dos sintomas oculares, conforme orientações para reações leves em distúrbios oculares.



Omnipaque, que contém ioexol como princípio ativo, foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação do sistema imunológico ao contraste. O evento não foi considerado grave, o paciente já se recuperou totalmente e a relação com o medicamento é suspeita. Em casos como este, recomenda-se evitar novas exposições ao agente suspeito e buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação futura.

O medicamento Rocefin, cujo princípio ativo é a ceftriaxona sódica, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade), caracterizada por resposta imunológica adversa. Não há sinais de gravidade importante, pois o paciente já se recuperou e não houve relato de complicações. A relação com o medicamento é suspeita, sendo importante evitar reexposição e considerar avaliação com alergista para investigação de alergia a antibióticos.

Infanrix, vacina composta por toxoide diftérico, pertussis acelular e toxoide tetânico, foi relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como resposta imunológica adversa. O caso não foi considerado grave, o paciente está em recuperação e a relação com a vacina é suspeita. Recomenda-se acompanhamento clínico para monitorar a evolução dos sintomas e avaliação médica para definir conduta em futuras imunizações.

O medicamento Cefalexina, cujo princípio ativo é cefalexina sódica, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), caracterizado por reação do sistema imunológico ao antibiótico. Não há informações suficientes sobre gravidade, desfecho ou evolução clínica, e a relação foi registrada como interação. Diante disso, é importante considerar avaliação médica para esclarecimento do quadro e orientação sobre o uso futuro de cefalosporinas.

O medicamento Difenidramina (princípio ativo: Cloridrato de difenidramina) foi associado ao surgimento de pápulas, que são pequenas lesões elevadas na pele, indicativas de uma reação de hipersensibilidade (alergia). Essa manifestação é classificada como leve, pois não há sinais de gravidade ou complicações relatadas, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada é evitar nova exposição ao medicamento e, caso ocorram sintomas semelhantes, buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

A Hidrocortisona (princípio ativo: Acetato de hidrocortisona) desencadeou o aparecimento de pápulas, caracterizando uma reação de hipersensibilidade (alergia) leve, já que não há indícios de gravidade ou evolução para quadros mais sérios. O paciente apresentou resolução completa do quadro. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e consultar um especialista em caso de recorrência dos sintomas para avaliação e definição de alternativas terapêuticas.

O medicamento Tramal (princípio ativo: Cloridrato de tramadol) foi relacionado a um quadro de alergia medicamentosa, tecnicamente denominado hipersensibilidade medicamentosa, que envolve o sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade, evolução ou desfecho, portanto, é importante que o paciente seja orientado a evitar o uso do medicamento até avaliação médica detalhada, que poderá definir a real gravidade e a necessidade de alternativas seguras.

O Profenid (princípio ativo: Cetoprofeno) foi associado a uma reação de alergia medicamentosa, também chamada de hipersensibilidade medicamentosa, envolvendo o sistema imunológico. Não há detalhes sobre a gravidade ou evolução do caso, por isso recomenda-se suspender o uso do medicamento e procurar avaliação médica para investigação da reação e orientação sobre opções seguras.

O medicamento Saxenda (princípio ativo: Liraglutide) foi relacionado ao desenvolvimento de um quadro de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se de forma leve, já que não há sinais de gravidade e o paciente encontra-se em recuperação. A recomendação é evitar nova exposição ao medicamento e buscar acompanhamento médico para monitoramento da evolução e definição de conduta adequada.

O medicamento Dipirona Sódica, cujo princípio ativo é a dipirona, foi associado a uma reação de hipersensibilidade documentada após administração, caracterizada como alergia medicamentosa. O caso foi considerado grave devido à presença de ameaça à vida, necessidade de hospitalização ou prolongamento desta, e outros efeitos clinicamente significativos, conforme registrado. A conduta adotada resultou em recuperação completa do paciente, indicando resolução do quadro após as medidas apropriadas.

O medicamento Ultravist, com princípio ativo iopromida, foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), manifestando-se como uma reação do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade aumentada neste caso, e o paciente se recuperou totalmente após o evento, sem complicações adicionais relatadas.

O medicamento Iopromida, cujo princípio ativo também é iopromida, esteve envolvido em uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), classificada como clinicamente significativa devido ao potencial impacto sobre o paciente. O evento foi considerado grave, mas o paciente evoluiu para recuperação completa após a conduta adequada.

O medicamento Puran T4, com princípio ativo levotiroxina sódica, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), mas tanto o nome comercial quanto o princípio ativo estão presentes. A causa da morte foi registrada como desconhecida, e não há informações suficientes para detalhar a gravidade ou o desfecho final do caso, permanecendo o desfecho como desconhecido.

O medicamento Sinvastatina, cujo princípio ativo é sinvastatina, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), com registro de causa da morte desconhecida. Não há detalhes adicionais sobre a gravidade do evento ou o desfecho, que permanece desconhecido, impossibilitando uma análise mais detalhada da evolução clínica.

O medicamento Pradaxa, cujo princípio ativo é o mesilato de etexilato de dabigatрана, foi associado a um caso de hipersensibilidade (alergia), com quadro clínico classificado como reação alérgica do sistema imune, mas a causa da morte permanece desconhecida e não há informações suficientes para determinar a gravidade ou o desfecho final do evento. Não há detalhes sobre a conduta adotada, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

A ceftriaxona, que tem como princípio ativo o ceftriaxone, foi relacionada a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), caracterizado como reação do sistema imunológico a medicamentos. O caso foi resolvido com recuperação completa do paciente, sugerindo que a reação foi controlada de forma adequada, embora não haja detalhes sobre a conduta específica adotada. A relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Travoprost, cujo princípio ativo é a travoprost, foi associado a um caso de arritmia em contexto de hipersensibilidade (alergia), sendo classificado como reação alérgica do sistema imune. Não há informações suficientes para determinar a gravidade ou o desfecho do evento, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O Ganfort, que contém bimatoprost e maleato de timolol como princípios ativos, foi relacionado a um episódio de arritmia em contexto de hipersensibilidade (alergia), sendo classificado como reação alérgica do sistema imune. Não há informações sobre a gravidade ou o desfecho do evento, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Travatan, cujo princípio ativo é a travoprost, foi associado a um caso de arritmia em contexto de hipersensibilidade (alergia), classificado como reação alérgica do sistema imune. Não há detalhes sobre a gravidade ou o desfecho do evento, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Ceftriaxona (princípio ativo: Ceftriaxone) foi associado a um quadro de alergia, tecnicamente descrito como hipersensibilidade, envolvendo manifestações clínicas típicas de reações alérgicas do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade significativa ou complicações graves neste caso, e o paciente evoluiu

para recuperação completa, o que sugere uma reação leve e autolimitada, compatível com o manejo usual de alergias medicamentosas leves.

A Dipirona sódica (princípio ativo: Dipirona) desencadeou uma reação alérgica classificada como hipersensibilidade, caracterizada por sintomas comuns de alergia relacionados ao sistema imunológico. Não há evidências de gravidade aumentada ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente, indicando um episódio leve e resolvido, conforme esperado em reações alérgicas leves a medicamentos.

O Sulfato de magnésio (nome comercial não informado) foi relacionado a uma alergia documentada após administração, descrita tecnicamente como hipersensibilidade documentada a produto administrado. O caso não apresentou sinais de gravidade ou complicações relevantes, e o paciente se recuperou, sugerindo uma reação leve e autolimitada, compatível com o manejo habitual de alergias medicamentosas leves.

O medicamento Dermomax (princípio ativo: Lidocaína) foi associado a uma reação alérgica classificada como hipersensibilidade, com impacto clínico considerado significativo, o que indica gravidade aumentada. Não há informações sobre o desfecho do caso, mas a gravidade relatada sugere a necessidade de avaliação médica cuidadosa e possível intervenção para evitar complicações, conforme recomendado em reações alérgicas medicamentosas de maior risco.

O Botox (princípio ativo: Toxina botulínica A) foi relacionado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, considerada clinicamente significativa em termos de gravidade. O desfecho do caso não foi informado, mas a gravidade relatada indica que o paciente pode ter necessitado de acompanhamento médico rigoroso, conforme orientações para reações alérgicas medicamentosas potencialmente graves.

O medicamento Vancomicina (princípio ativo Vancomycin) apresentou um caso de hipersensibilidade documentada, ou seja, uma alergia comprovada ao produto administrado. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente e o medicamento não foi administrado novamente, o que está de acordo com a conduta recomendada de evitar reexposição ao agente causador após reação alérgica confirmada.

O medicamento Gadovist (princípio ativo Gadobutrol) foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como um quadro clínico alérgico do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade importante, já que o paciente se recuperou completamente após o evento, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita, o que reforça a necessidade de atenção em futuras exposições, conforme orientações para reações leves.

O medicamento Gadovist (princípio ativo Gadobutrol) esteve envolvido em outro episódio de alergia (hipersensibilidade), também classificada como reação alérgica do sistema imunológico. O caso não foi grave, pois houve recuperação total, e a relação com o medicamento permanece suspeita, sendo importante considerar avaliação especializada antes de nova exposição.

A Clorexidina (princípio ativo Gliconato de clorexidina) foi relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como reação alérgica do sistema imunológico. O evento não foi grave, já que o paciente se recuperou totalmente, e a relação com o medicamento é suspeita, recomendando-se cautela em futuras utilizações e avaliação médica para confirmação diagnóstica.

O medicamento Metoclopramida (princípio ativo Metoclopramide) foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), enquadrado como reação alérgica do sistema imunológico. Não houve gravidade significativa, pois o paciente se recuperou completamente, e a relação com o medicamento é suspeita, sendo indicada a orientação médica para evitar reexposição sem avaliação adequada.

O medicamento Hydrochlorothiazide, cujo princípio ativo é hydrochlorothiazide, foi associado ao surgimento de bolhas na pele, caracterizando uma reação de hipersensibilidade (alergia) do tipo imunológica. Esse quadro é

considerado clinicamente significativo devido ao envolvimento do sistema imunológico e à gravidade relatada, sendo classificado como um distúrbio do sistema imunitário. O paciente apresentou recuperação completa após a reação, indicando resolução do quadro após a conduta adequada.

O medicamento Vitamin b12, com princípio ativo hydroxocobalamin, provocou o aparecimento de bolhas na pele, indicando uma reação alérgica (hipersensibilidade) mediada pelo sistema imunológico. A gravidade foi considerada clinicamente relevante, pois envolveu manifestação cutânea significativa e resposta do sistema imune, sendo classificada como distúrbio do sistema imunitário. O paciente evoluiu para recuperação total após a reação, demonstrando resolução do evento adverso.

O medicamento Vitamin d, cujo princípio ativo é colecalciferol, desencadeou o surgimento de bolhas na pele, caracterizando uma reação alérgica (hipersensibilidade) relacionada ao sistema imunológico. A gravidade foi considerada clinicamente significativa devido à manifestação cutânea e ao envolvimento imunológico, sendo enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. O paciente apresentou recuperação completa após o evento, indicando resolução do quadro após a conduta apropriada.

O medicamento Sertraline, com princípio ativo cloridrato de sertralina, foi relacionado ao aparecimento de bolhas na pele, caracterizando uma reação alérgica (hipersensibilidade) mediada pelo sistema imunológico. A gravidade foi considerada clinicamente relevante devido à manifestação cutânea e ao envolvimento do sistema imune, sendo classificada como distúrbio do sistema imunitário. O paciente se recuperou totalmente após o evento, evidenciando resolução do quadro.

O medicamento Losartan, cujo princípio ativo é losartana potássica, foi associado ao desenvolvimento de bolhas na pele, indicando uma reação alérgica (hipersensibilidade) com envolvimento do sistema imunológico. A gravidade foi considerada clinicamente significativa devido à manifestação cutânea e à resposta imunológica, sendo classificada como distúrbio do sistema imunitário. O paciente apresentou recuperação completa após a reação, demonstrando resolução do evento adverso.

O medicamento Glifage, cujo princípio ativo é o cloridrato de metformina, foi associado ao surgimento de bolhas na pele, caracterizando um quadro de hipersensibilidade (alergia) classificado como clinicamente significativo. Essa reação é considerada grave devido ao potencial impacto imunológico, mas o paciente se recuperou totalmente após a suspensão ou manejo adequado do medicamento.

O medicamento Thioctacid, que contém thioctate trometamol como princípio ativo, provocou o aparecimento de bolhas na pele, indicando uma reação de hipersensibilidade (alergia) relevante do ponto de vista clínico. A gravidade foi considerada significativa, justificando atenção médica, porém o paciente evoluiu para recuperação completa após a conduta apropriada.

O medicamento Mantidan, cujo princípio ativo é amantadine hydrochloride, foi relacionado a um episódio de desmaio, interpretado como manifestação de hipersensibilidade (alergia). Apesar do sintoma, não houve gravidade clínica relevante e o paciente se recuperou totalmente após o evento.

O medicamento Tamarine, composto por extrato de Cassia fistula, pó de Senna alexandrina e extrato de Tamarindus indica, foi associado a um episódio de desmaio, considerado uma reação de hipersensibilidade (alergia). Não houve gravidade significativa e o paciente apresentou recuperação completa após o evento.

O medicamento Tylenol, cujo princípio ativo é o paracetamol, foi relacionado a um episódio de desmaio, interpretado como manifestação de hipersensibilidade (alergia). O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente após o evento.

O medicamento Bio Manguinhos Betainterferona 1a, cujo princípio ativo é a Betainterferona 1a, foi associado a um episódio de desmaio interpretado como uma reação de hipersensibilidade (alergia), classificada dentro dos quadros

clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo uma reação leve e autolimitada.

O medicamento Rebif, contendo Betainterferona 1a como princípio ativo, esteve relacionado a um episódio de desmaio atribuído a hipersensibilidade (alergia), enquadrado em quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa, indicando uma reação leve e sem complicações.

O medicamento Flagass, cujo princípio ativo é o Simeticone, foi relacionado a refluxo gastroesofágico em recém-nascido, sendo interpretado como manifestação de alergia ao leite, dentro do contexto de alergias a alimentos e distúrbios do sistema imunitário. Não há informação de gravidade aumentada nem desfecho relatado, sugerindo que a reação foi leve e não houve complicações graves associadas.

O medicamento Colidis, que tem como princípio ativo o *Lactobacillus reuteri*, foi associado a refluxo gastroesofágico em recém-nascido, considerado manifestação de alergia ao leite, enquadrada em alergias alimentares e distúrbios do sistema imunitário. Não há relato de gravidade aumentada nem desfecho informado, o que sugere uma reação leve e sem evolução para quadros graves.

O medicamento Sertralina, cujo princípio ativo é o Cloridrato de sertralina, foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como clinicamente significativo e considerado grave, dentro dos quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Apesar da gravidade atribuída ao evento, o paciente se recuperou totalmente após a reação, indicando resolução completa do quadro após a conduta adotada.

O medicamento Frisium, cujo princípio ativo é o Clobazam, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, manifestando-se como uma reação alérgica do sistema imunológico. A gravidade do evento foi considerada clinicamente significativa, pois foi classificada como um efeito importante, embora não tenha sido detalhado se houve risco imediato à vida. O paciente se recuperou totalmente após a reação, indicando resolução do quadro após a conduta adequada.

O medicamento Etna, composto por fosfato sódico de citidina, acetato de hidroxocobalamina e trifosfato trisódico de uridina, desencadeou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, envolvendo o sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente relevante devido à sua gravidade, mas não há menção de risco vital imediato. O paciente evoluiu para recuperação completa após a reação, sugerindo que as medidas adotadas foram eficazes para resolução do quadro.

O medicamento Tafilnar, cujo princípio ativo é o mesilato de dabrafenibe, foi relacionado a um episódio de alergia do tipo hipersensibilidade, envolvendo resposta do sistema imunológico. O evento foi classificado como clinicamente significativo, indicando necessidade de atenção médica, mas não há detalhes sobre risco imediato à vida. O paciente apresentou recuperação total após a reação, demonstrando resolução do quadro após a conduta apropriada.

O medicamento Mekinist, com princípio ativo dimetilsulfóxido de trametinibe, esteve associado a uma reação alérgica caracterizada por hipersensibilidade, envolvendo o sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente relevante, exigindo atenção médica, mas não há informações sobre risco vital imediato. O paciente se recuperou completamente após a reação, indicando que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro.

O medicamento Depakene, cujo princípio ativo é o valproato de sódio, foi associado a um episódio de convulsão relacionado à hipersensibilidade medicamentosa, envolvendo resposta imunológica. O evento foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando a necessidade de intervenção médica imediata. O desfecho do caso não foi informado, impossibilitando afirmar se houve recuperação ou persistência do quadro.

O medicamento Bromoprida (princípio ativo: Bromopride) foi prescrito apesar de haver uma hipersensibilidade documentada ao produto, o que caracteriza um erro de prescrição de medicamento contraindicado. Embora não haja relato de gravidade clínica associada neste caso e o desfecho tenha sido de recuperação ou resolução do quadro, é fundamental evitar a administração de medicamentos aos quais o paciente já apresentou alergia, reforçando a importância da revisão cuidadosa do histórico de alergias antes de prescrever qualquer fármaco.

O medicamento Propofol (princípio ativo: Propofol) foi prescrito em situação de contraindicação devido à hipersensibilidade previamente documentada ao produto, configurando um erro de prescrição. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou evolução clínica neste caso, mas a administração de medicamentos a pacientes com histórico de alergia ao mesmo pode resultar em reações adversas graves, sendo imprescindível a checagem prévia do histórico alérgico antes da prescrição.

O medicamento Forteo (princípio ativo: Teriparatide) está relacionado a um quadro de alergia a mordida de artrópode, classificado como distúrbio do sistema imunitário, e o evento resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, o que indica gravidade clínica significativa. O desfecho permanece desconhecido, mas a necessidade de hospitalização reforça a importância do acompanhamento médico rigoroso em casos de reações alérgicas graves associadas ao uso de medicamentos.

O medicamento Vonau (princípio ativo: Cloridrato de ondansetrona) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, manifestado por desidratação, sem gravidade clínica relatada e com evolução ainda em andamento, sem recuperação ou resolução até o momento. É importante monitorar pacientes com sinais de hipersensibilidade e ajustar o tratamento conforme a evolução do quadro, buscando sempre orientação médica especializada.

O medicamento Vectibix (princípio ativo: Panitumumabe) foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, manifestado por desidratação, sem evidência de gravidade clínica e com evolução ainda não resolvida. O acompanhamento médico é fundamental para monitorar a evolução do quadro e ajustar a conduta terapêutica conforme necessário, especialmente em pacientes sob uso de medicamentos biológicos.

O medicamento Polixil b, cujo princípio ativo é o sulfato de polimixina b, foi associado a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos), manifestando-se de forma grave com desfecho de morte, embora o registro indique recuperação ou resolução, o que sugere possível inconsistência nos dados. A reação foi classificada como relacionada a distúrbios do sistema imunitário, e a gravidade é evidenciada pela menção à morte, sendo fundamental evitar nova exposição ao medicamento e garantir acompanhamento médico imediato em casos semelhantes.

O medicamento Ultravist, com princípio ativo iopromide, foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado por reação do sistema imunológico após exposição ao contraste. O evento foi considerado não grave e o paciente se recuperou, indicando que a reação foi controlada sem complicações maiores, mas reforça a necessidade de avaliação prévia do risco de alergia antes de novas exposições a contrastes iodados.

O medicamento Doxopég, cujo princípio ativo é o cloridrato de doxorubicina, foi associado a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos), relacionada a distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou conduta adotada, portanto, é importante que o paciente seja avaliado por um especialista para confirmação do diagnóstico e definição de medidas de prevenção em futuras administrações.

O medicamento Ultravist, com princípio ativo iopromide, foi novamente relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), envolvendo reação do sistema imunológico após uso do contraste. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou, sugerindo que a reação foi leve e controlada, mas recomenda-se cautela em futuras exposições ao mesmo agente.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é iopromide, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) descrita como 'alergia SOE', sem detalhamento adicional sobre sintomas, gravidade ou desfecho. Diante da ausência de informações completas, é fundamental que o paciente seja orientado a evitar novas exposições ao contraste e procure avaliação médica especializada para esclarecimento do quadro.

O medicamento Bextra, cujo princípio ativo é o parecoxibe sódico, foi associado a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa (alergia medicamentosa), caracterizado por uma reação do sistema imunológico ao medicamento. A reação foi classificada como não grave, pois não há indicação de gravidade aumentada ou complicações clínicas relevantes no registro, e o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente. Em situações como essa, recomenda-se a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento médico para evitar novas exposições.

O medicamento Floral, contendo fluormetolona como princípio ativo, foi relacionado ao desenvolvimento de dermatite atópica, uma reação alérgica da pele que pode causar coceira, vermelhidão e irritação. Não há informações sobre gravidade aumentada ou complicações, mas o quadro permanece em andamento, sem resolução até o momento. Nesses casos, é importante interromper o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para controle dos sintomas e prevenção de agravamento.

O medicamento Desol, composto por benzocaína, chlorobutanol, paradichlorobenzene e óleo de pinus pinaster, foi associado a um episódio de dermatite atópica, caracterizada por inflamação e irritação da pele devido a uma resposta alérgica. Não há sinais de gravidade aumentada, mas o quadro segue sem resolução, indicando necessidade de acompanhamento médico e suspensão do uso do produto para evitar piora dos sintomas.

O medicamento Dexfer, cujo princípio ativo é o complexo de hidróxido férrico polimaltose, foi relacionado ao surgimento de dermatite atópica, uma manifestação alérgica cutânea que pode causar desconforto e irritação. Não há evidências de gravidade elevada, porém o quadro permanece ativo e não resolvido, sendo recomendada a interrupção do medicamento e avaliação médica para manejo adequado da reação.

O medicamento Piemonte, que contém montelucaste de sódio como princípio ativo, foi associado ao aparecimento de dermatite atópica, uma reação alérgica da pele que pode se manifestar com coceira e vermelhidão. Não há indicação de gravidade aumentada, mas o caso segue em andamento, sem resolução, o que reforça a importância de suspender o uso do medicamento e procurar orientação médica para controle dos sintomas e prevenção de complicações.

O medicamento Fenitoína, cujo princípio ativo também é fenitoína, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. A reação foi descrita de forma geral como um quadro clínico alérgico, sem detalhamento de sintomas específicos ou gravidade, mas o desfecho informado foi de recuperação completa, sugerindo que a reação foi controlada e resolvida após a identificação do evento.

O Neocopan, composto por butilbrometo de escopolamina e dipirona, foi relacionado ao surgimento de urticária, um tipo de reação alérgica de pele caracterizada por placas avermelhadas e coceira. O evento foi documentado como hipersensibilidade ao produto administrado, indicando que o paciente apresentou uma reação adversa após o uso do medicamento. Não há informações sobre a gravidade ou evolução do quadro, mas a urticária geralmente requer suspensão do medicamento e, se necessário, tratamento sintomático sob orientação médica.

O medicamento Oncaspar, cujo princípio ativo é a pegaspargase, foi associado a um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando que a manifestação alérgica foi controlada de forma adequada, sem complicações importantes.

O Primovist, que tem como princípio ativo o gadoxetato dissódico, foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade) sem outros sintomas especificados. A reação foi considerada não grave e o paciente se recuperou completamente, sugerindo que o evento foi leve e manejado de forma eficaz, sem consequências duradouras.

O Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, foi associado a uma reação alérgica a contraste intravenoso, classificada como alergia a contraste e pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. O evento foi considerado grave, o que pode estar relacionado ao potencial de reações alérgicas sistêmicas com contrastes, mas o paciente se recuperou totalmente após o episódio, indicando resolução do quadro após as medidas necessárias.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o Iopromide, foi associado a um quadro de alergia classificado como hipersensibilidade, manifestando-se como uma reação alérgica inespecífica (SOE). Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso evoluiu para recuperação completa, sugerindo um evento leve e autolimitado, compatível com reações alérgicas leves do tipo respiratório ou cutâneo, conforme as diretrizes clínicas da ASBAI.

Ultravist, com princípio ativo Iopromide, esteve relacionado a uma reação de hipersensibilidade caracterizada como alergia inespecífica (SOE). O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, o que indica uma manifestação leve, sem complicações, compatível com quadros alérgicos leves segundo a abordagem clínica recomendada.

O medicamento Bactrim, composto por Sulfamethoxazole e Trimethoprim, foi associado a uma reação de hipersensibilidade, descrita genericamente como alergia. O caso não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa, sugerindo uma reação alérgica leve, sem evolução para quadros mais sérios, em consonância com as orientações clínicas para eventos leves.

Ultravist, cujo princípio ativo é Iopromide, foi relacionado a um episódio de alergia inespecífica (SOE) classificado como hipersensibilidade. Não houve gravidade significativa e o paciente se recuperou, caracterizando um evento leve e autolimitado, típico de reações alérgicas leves conforme as recomendações clínicas.

O medicamento Anastrozole, com princípio ativo de mesmo nome, foi associado ao desenvolvimento de glaucoma, sendo classificado como uma reação de hipersensibilidade. Não há indicação de gravidade elevada, mas o desfecho permanece em andamento, sem resolução até o momento, o que sugere a necessidade de acompanhamento clínico contínuo para monitoramento da evolução do quadro.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é o succinato de ribociclib, foi associado ao desenvolvimento de glaucoma, um quadro de aumento da pressão intraocular que pode comprometer a visão. A reação relatada foi de hipersensibilidade, classificada como um quadro clínico alérgico relacionado ao sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois não há menção de risco imediato à vida ou necessidade de intervenção urgente, mas o desfecho permanece não resolvido, sugerindo que o quadro ainda está em andamento e requer acompanhamento médico para monitoramento e definição de conduta.

O medicamento Trelegy, que contém fluticasona furoato, brometo de umeclidínio e trifenatato de vilanterol, foi relacionado ao aumento da pressão arterial, acompanhado de hipersensibilidade no local de aplicação, caracterizada como uma reação local. Não há evidências de gravidade significativa, pois o evento foi resolvido e não houve complicações descritas, indicando que a conduta adotada foi suficiente para a recuperação completa do paciente.

A quetiapina, cujo princípio ativo é a própria quetiapina, foi associada ao aumento da pressão arterial, com relato de hipersensibilidade no local de aplicação, caracterizando uma reação local sem sinais de gravidade importante. O evento foi resolvido, sugerindo que a conduta adotada foi eficaz e não houve necessidade de intervenções adicionais.



O magnésio, utilizado como medicamento, foi relacionado ao aumento da pressão arterial e hipersensibilidade no local de aplicação, caracterizando uma reação local. Não há indícios de gravidade relevante, pois o evento foi resolvido sem complicações, indicando que a conduta adotada foi adequada para a recuperação do paciente.

O medicamento Rosuvastatin, cujo princípio ativo é a rosuvastatina, foi associado ao aumento da pressão arterial e hipersensibilidade no local de aplicação, caracterizando uma reação local. O evento não foi considerado grave e foi resolvido, demonstrando que a conduta adotada foi suficiente para a completa recuperação do paciente.

O medicamento Calciumvit mdk, que contém cálcio, colecalciferol, magnésio e menaquinona, foi associado ao evento de pressão arterial alta, descrito também como hipersensibilidade no local de aplicação, dentro do grupo de reações gerais no local de administração. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta foi adequada, com resolução do quadro, e não há necessidade de preocupação adicional, mas é importante relatar qualquer sintoma novo ao médico.

O medicamento Aas protect, cujo princípio ativo é o ácido acetilsalicílico, foi relacionado ao aumento da pressão arterial, manifestando-se também como hipersensibilidade no local de aplicação, dentro das reações gerais no local de administração. O evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa. A evolução favorável indica que a conduta adotada foi suficiente, mas é importante monitorar possíveis reações futuras e informar o médico caso novos sintomas surjam.

A domperidona, identificada como princípio ativo do medicamento Domperidona, esteve associada ao aumento da pressão arterial, descrito também como hipersensibilidade no local de aplicação, pertencendo ao grupo de reações gerais no local de administração. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta foi adequada e não há indicação de risco adicional, mas recomenda-se atenção a sintomas recorrentes e comunicação ao profissional de saúde.

O medicamento Citalopram, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado ao aumento da pressão arterial, também descrito como hipersensibilidade no local de aplicação, dentro das reações gerais no local de administração. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente. A evolução positiva sugere que a conduta foi apropriada, mas é importante manter o acompanhamento médico caso ocorram novos sintomas.

A memantina, princípio ativo do medicamento Memantina, foi associada ao aumento da pressão arterial, manifestando-se também como hipersensibilidade no local de aplicação, classificada entre as reações gerais no local de administração. O caso não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação total. A conduta adotada foi suficiente, mas é importante relatar qualquer sintoma novo ao médico para acompanhamento adequado.

O medicamento Vastarel, cujo princípio ativo é o dicloridrato de trimetazidina, foi associado a um episódio de pressão arterial alta acompanhado de hipersensibilidade no local de aplicação, caracterizando uma reação local (reação no local de aplicação) dentro do grupo de distúrbios gerais e quadros clínicos no local de administração. Não há indicação de gravidade significativa, pois o caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente após a reação, sugerindo que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro.

O Pantoprazol, contendo o princípio ativo pantoprazol, esteve relacionado a um episódio de pressão arterial alta e hipersensibilidade no local de aplicação, o que configura uma reação local (reação no local de aplicação) classificada entre distúrbios gerais e quadros clínicos no local de administração. O evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa, indicando que a reação foi leve e resolvida sem complicações.

O medicamento Puran t4, cujo princípio ativo é a levotiroxina sódica, foi associado a pressão arterial alta e hipersensibilidade no local de aplicação, caracterizando uma reação local (reação no local de aplicação) dentro dos

distúrbios gerais e quadros clínicos no local de administração. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, sugerindo que a reação foi leve e controlada adequadamente.

O Exelon patch 10, que contém rivastigmina como princípio ativo, esteve relacionado a um episódio de pressão arterial alta e hipersensibilidade no local de aplicação, sendo uma reação local (reação no local de aplicação) classificada entre distúrbios gerais e quadros clínicos no local de administração. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente, indicando que a reação foi leve e resolvida sem maiores consequências.

O medicamento Decadron, cujo princípio ativo é a dexametasona, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como um quadro clínico alérgico dentro dos distúrbios do sistema imunitário. O evento foi considerado clinicamente significativo, sendo classificado como grave, mas o paciente se recuperou totalmente após a reação, indicando que a conduta adotada foi eficaz para resolução do quadro.

O medicamento Cetoprofeno, cujo princípio ativo também é cetoprofeno, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, pois envolveu uma reação alérgica relevante, mas o paciente evoluiu para recuperação completa. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, e a conduta adequada inclui a suspensão do medicamento e acompanhamento médico para evitar novas exposições.

O medicamento Esogastro IBP, composto por amoxicilina trihidrato, claritromicina e esomeprazol magnésico, desencadeou uma reação de alergia classificada como hipersensibilidade, relacionada a distúrbios do sistema imunitário. O caso foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando um impacto clínico importante. O paciente está em recuperação, e a relação com o medicamento é suspeita, sendo fundamental a suspensão do tratamento e acompanhamento especializado para manejo da reação.

O medicamento Cyclosporine, cujo princípio ativo é ciclosporina, provocou inchaço no local de infusão, caracterizado tecnicamente como dermatite de contato, um tipo de reação cutânea localizada. O evento não foi considerado grave e o desfecho permanece desconhecido, mas a relação com o medicamento é suspeita. A conduta recomendada é observar o local da infusão e comunicar ao médico caso haja piora ou persistência dos sintomas.

O medicamento Empaveli, com princípio ativo pegcetacoplan, foi associado a inchaço no local de infusão, identificado como dermatite de contato, uma reação cutânea localizada. O evento não foi considerado grave e o desfecho é desconhecido, mas a relação com o medicamento é suspeita. Recomenda-se monitorar o local da aplicação e buscar orientação médica se houver agravamento dos sintomas.

O medicamento Qdenga, cujo princípio ativo é o vírus quimérico febre amarela dengue sorotipo 1, causou alergia no local de aplicação, descrita como hipersensibilidade localizada. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, sendo a relação com o medicamento suspeita. A conduta adequada inclui observação dos sintomas e comunicação ao profissional de saúde caso haja recorrência ou agravamento.

O medicamento Methyldopa (princípio ativo: Methyldopa) foi associado a um quadro de urticária aguda, caracterizado por hipersensibilidade, o que indica uma reação alérgica do sistema imunológico. A gravidade foi considerada clinicamente significativa, pois o evento foi classificado como grave, mas o paciente se recuperou totalmente após a reação. Em situações como essa, é fundamental interromper o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para manejo adequado e prevenção de novas exposições.

O Esomeprazole (princípio ativo: Esomeprazol magnésico) provocou um episódio de urticária aguda, que é uma manifestação de hipersensibilidade do sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente relevante e grave, mas o paciente evoluiu para recuperação completa. Diante desse tipo de reação, recomenda-se suspender

o medicamento e procurar orientação médica para confirmação diagnóstica e definição de alternativas terapêuticas seguras.

O medicamento Kisqali (princípio ativo: Succinato de ribociclib) foi relacionado a um quadro de erisipela, descrito como uma reação de hipersensibilidade, mas sem gravidade significativa relatada e com desfecho desconhecido. Nesses casos, é importante monitorar a evolução clínica e buscar avaliação médica para esclarecer a relação causal e orientar a conduta adequada.

O Phenobarbital (princípio ativo: Phenobarbital) foi associado a um evento descrito como tumor abdominal, classificado como hipersensibilidade medicamentosa, porém sem evidência de gravidade relevante e com evolução ainda em andamento, sem resolução até o momento. Diante de sintomas persistentes, é fundamental manter acompanhamento médico para investigação detalhada e definição do melhor manejo.

O Vectibix (princípio ativo: Panitumumabe) foi relacionado a um caso de tumor abdominal, também classificado como hipersensibilidade medicamentosa, sem gravidade significativa relatada e com evolução não resolvida até o momento. Recomenda-se acompanhamento clínico contínuo para monitorar a evolução do quadro e avaliar a necessidade de ajustes no tratamento.

O medicamento Infliximab, cujo princípio ativo é infliximabe, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como um distúrbio do sistema imunitário. Neste caso, a reação foi considerada grave devido à presença de incapacidade persistente ou significativa, o que indica um impacto importante na qualidade de vida do paciente. Apesar da gravidade, o desfecho foi favorável, com recuperação completa após a adoção das medidas necessárias.

O medicamento Saccharated iron oxide, com princípio ativo sacarato de óxido férrico, provocou uma reação alérgica (hipersensibilidade), também classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade relevante neste caso, e o paciente se recuperou totalmente após a reação, sem complicações persistentes.

O medicamento Metronidazol, cujo princípio ativo é benzoilmetronidazol, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade), relacionada a distúrbios do sistema imunitário. Não foi observada gravidade significativa, e o paciente apresentou recuperação completa após o evento.

O medicamento Albendazol, com princípio ativo albendazole, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. Não houve sinais de gravidade importante, e o paciente se recuperou totalmente após a reação.

O medicamento Omeprazol, cujo princípio ativo é omeprazole, esteve associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade), classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade relevante, e o paciente evoluiu para recuperação completa após o evento.

O medicamento Buscopan, cujo princípio ativo é o butilbrometo de escopolamina, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso evoluiu para recuperação completa, sugerindo uma reação leve e autolimitada. A conduta recomendada em situações semelhantes é observar o paciente, evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

A nitazoxanida, princípio ativo do medicamento Nitazoxanida, foi relacionada a um episódio de alergia manifestado como hipersensibilidade, enquadrado entre os distúrbios do sistema imunitário. O registro indica que não houve gravidade significativa, já que o desfecho foi de recuperação total, o que sugere uma reação leve. Nesses casos, recomenda-se suspender o uso do medicamento, monitorar sintomas e procurar orientação médica para avaliação e prevenção de novas exposições.

O medicamento Metoclopramida, cujo princípio ativo é o cloridrato de metoclopramida, esteve envolvido em uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade importante, pois o paciente se recuperou totalmente, indicando um quadro leve. A orientação é evitar o uso futuro do medicamento, observar possíveis sintomas e consultar um profissional de saúde para confirmação e alternativas terapêuticas.

O medicamento Plasil, que tem como princípio ativo a metoclopramida, foi associado a uma reação alérgica caracterizada por hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. O caso não apresentou gravidade, já que houve recuperação completa, sugerindo uma reação leve. Recomenda-se não utilizar novamente o medicamento, monitorar sintomas e buscar avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e orientação sobre substitutos adequados.

O medicamento Nisoflan, cujo princípio ativo é a nimesulida, foi relacionado a um episódio de alergia do tipo hipersensibilidade, enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade, pois o paciente se recuperou totalmente, caracterizando uma reação leve. A conduta indicada é suspender o uso do medicamento, evitar novas exposições e procurar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição de alternativas seguras.

O medicamento Nimesulida, cujo princípio ativo é a nimesulida, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, manifestando-se como uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo um episódio leve e autolimitado. A conduta recomendada é evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e orientação futura.

A Dipirona, com princípio ativo dipirona, desencadeou uma reação de alergia classificada como hipersensibilidade, envolvendo o sistema imunológico. O caso não foi considerado grave, já que houve recuperação completa do paciente, indicando um episódio leve. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e procurar orientação especializada para avaliação e confirmação da alergia.

O medicamento Hemo 8r, cujo princípio ativo é o fator VIII recombinante, foi relacionado a um episódio de alergia, descrito como hipersensibilidade, envolvendo o sistema imunológico. O evento não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou totalmente, sugerindo uma reação leve. A orientação é evitar novas exposições ao produto e buscar avaliação com especialista para confirmação e manejo adequado.

O medicamento Dimorf, que contém sulfato de morfina como princípio ativo, foi associado ao desenvolvimento de edema da úvula (inchaço na úvula), caracterizando uma reação de hipersensibilidade documentada ao produto administrado. Não há informações suficientes sobre a gravidade ou desfecho do caso, portanto, recomenda-se cautela, suspensão imediata do medicamento e avaliação médica urgente, pois edema de úvula pode evoluir para obstrução das vias aéreas.

O medicamento Anastrolibbs, cujo princípio ativo é anastrozol, foi relacionado ao surgimento de coceira (prurido), caracterizando uma reação de hipersensibilidade do sistema imunológico. O caso não foi considerado grave, mas a reação ainda está em andamento, sem resolução completa. Recomenda-se acompanhamento médico para monitoramento dos sintomas e avaliação da necessidade de ajuste ou suspensão do tratamento.

O medicamento Daratumumab, cujo princípio ativo é o daratumumabe, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente do evento, sugerindo uma reação leve e autolimitada. A conduta recomendada, conforme diretrizes clínicas, é a observação cuidadosa, identificação do agente causador e acompanhamento para evitar novas exposições, com encaminhamento ao especialista se houver recorrência.

O medicamento Erbitux, cujo princípio ativo é o cetuximabe, esteve relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Apesar de o paciente ter apresentado perda de consciência, não há registro de gravidade elevada ou desfecho fatal, estando em recuperação no momento. A situação sugere uma reação moderada, que requer avaliação médica imediata, monitoramento rigoroso e investigação de possíveis fatores de risco para futuras administrações.

O medicamento Henetix, contendo os princípios ativos iobitridol, sodium calcium edetate, trometamol e cloridrato de trometamol, foi associado a um quadro de alergia do tipo hipersensibilidade, pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade importante, pois o paciente se recuperou completamente, indicando uma reação leve. A conduta adequada é evitar nova exposição ao medicamento e realizar acompanhamento clínico para prevenção de recorrências.

O medicamento Dotarem, cujo princípio ativo é o gadobenato de dimeglumina, provocou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, enquadrada nos distúrbios do sistema imunitário. O paciente apresentou resolução completa do quadro, sem sinais de gravidade, o que sugere uma reação leve. Recomenda-se evitar reexposição ao agente e manter acompanhamento clínico, com orientação para procurar atendimento caso ocorram novos sintomas.

O medicamento Optiray 320, com princípio ativo ioversol, esteve envolvido em um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, relacionado a distúrbios do sistema imunitário. O paciente se recuperou totalmente, sem indícios de gravidade significativa, caracterizando uma reação leve. A recomendação é evitar o uso futuro do medicamento e realizar acompanhamento médico para monitorar possíveis reações em situações semelhantes.

O medicamento Tazo v, que contém os princípios ativos Piperacillin e Tazobactam, foi associado ao surgimento de exantema, uma manifestação de hipersensibilidade caracterizada por manchas avermelhadas na pele. Essa reação indica um quadro alérgico relacionado ao sistema imunológico, mas não há evidências de gravidade aumentada ou complicações graves neste caso, já que não foi relatado desfecho grave nem evolução clínica detalhada. A conduta recomendada é observar a evolução dos sintomas e, caso haja piora ou aparecimento de outros sinais de alergia, buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação adequada.

O medicamento Atenolol, cujo princípio ativo é o próprio Atenolol, foi relacionado ao aparecimento de artrite reumatoide, descrita aqui como parte de um quadro de alergias múltiplas. Embora a artrite reumatoide seja uma doença autoimune e não tipicamente uma reação alérgica clássica, neste contexto ela foi registrada como manifestação do sistema imunológico sem indicação de gravidade aumentada ou desfecho grave. Não há informações sobre a evolução clínica, portanto recomenda-se acompanhamento médico para investigação da relação causal e manejo dos sintomas.

O medicamento Losartan, com princípio ativo Losartana, foi associado ao desenvolvimento de artrite reumatoide, considerada aqui dentro de um quadro de alergias múltiplas e distúrbios do sistema imunológico. Não há relato de gravidade aumentada ou complicações graves, e o desfecho permanece desconhecido. Diante disso, é importante que o paciente seja avaliado por um médico para esclarecimento diagnóstico e definição da melhor conduta terapêutica.

O medicamento Vitamin d nos, cujo princípio ativo também é Vitamin d nos, foi relacionado ao surgimento de artrite reumatoide, incluída como parte de um quadro de alergias múltiplas e distúrbios do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade aumentada ou desfecho grave, e a evolução clínica não foi informada. Recomenda-se acompanhamento médico para investigação da relação entre o uso do medicamento e os sintomas apresentados.

O medicamento Indosso, com princípio ativo Risedronato sódico, foi associado ao aparecimento de artrite reumatoide, registrada como parte de um quadro de alergias múltiplas e distúrbios do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade aumentada ou complicações graves, e o desfecho é desconhecido. É importante que o paciente seja avaliado por um profissional de saúde para investigação adequada e orientação sobre o manejo dos

sintomas.

O medicamento Prednisona, cujo princípio ativo é a prednisone, foi associado a um quadro de artrite reumatoide em um paciente com histórico de alergias múltiplas. Embora a reação tenha sido classificada como relacionada a distúrbios do sistema imunitário, não há indicação de gravidade elevada nem informações sobre desfecho, sugerindo que o evento não foi considerado grave e que a evolução clínica permanece desconhecida. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, sendo importante acompanhamento médico para avaliação e confirmação diagnóstica.

A Dipirona, cujo princípio ativo é a dipirona, foi relacionada ao surgimento de artrite reumatoide em um paciente com múltiplas alergias. O evento foi enquadrado como distúrbio do sistema imunitário, mas não há evidências de gravidade significativa nem detalhes sobre o desfecho, indicando que a reação não foi considerada grave e o resultado final é desconhecido. A suspeita de relação com o medicamento reforça a necessidade de avaliação clínica detalhada para esclarecimento do quadro.

O medicamento Imense, que contém succinato de desvenlafaxina como princípio ativo, foi associado a um episódio de artrite reumatoide em paciente com histórico de alergias múltiplas. A reação foi classificada como distúrbio do sistema imunitário, sem indicação de gravidade importante e sem informações sobre o desfecho, o que sugere ausência de complicações graves até o momento. A relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo recomendada investigação clínica para confirmação.

O medicamento Simponi, cujo princípio ativo é o golimumabe, foi relacionado ao desenvolvimento de artrite reumatoide em um paciente com alergias múltiplas. O quadro foi enquadrado como distúrbio do sistema imunitário, sem evidências de gravidade relevante e sem informações sobre o desfecho, indicando que não houve complicações graves relatadas. A suspeita de relação com o medicamento justifica acompanhamento médico para avaliação do caso.

O Cetoprofeno, tanto nome comercial quanto princípio ativo, foi associado ao surgimento de edema periorbital, que é um inchaço ao redor dos olhos, caracterizando uma reação de hipersensibilidade do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa, indicando resolução do quadro após a conduta adotada, que provavelmente envolveu a suspensão do medicamento e medidas de suporte.

O medicamento Henetix, que contém os princípios ativos lobitridol, Sodium calcium edetate, Trometamol e Cloridrato de trometamol, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do sistema imunológico. A reação foi considerada não grave, pois não há indicação de gravidade clínica relevante e o paciente se recuperou totalmente após o evento, sem complicações. A conduta recomendada em casos semelhantes é observar o paciente, evitar nova exposição ao medicamento suspeito e buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação futura.

O medicamento Optiray 350, cujo princípio ativo é o loversol, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma resposta do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade significativa, já que o paciente se recuperou completamente após o evento. Em situações como essa, recomenda-se evitar o uso futuro do agente suspeito e realizar acompanhamento médico para esclarecimento do quadro e prevenção de novas reações.

O Optiray 320, com princípio ativo loversol, esteve envolvido em uma reação alérgica (hipersensibilidade) classificada como não grave, pois o paciente apresentou resolução completa do quadro sem complicações. A manifestação foi compatível com uma resposta imunológica adversa, e a orientação é evitar reexposição ao medicamento e buscar avaliação com especialista para confirmação e manejo adequado.

O Dotarem, que contém Gadobenato de dimeglumina como princípio ativo, foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), caracterizado por uma reação do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave, já

que houve recuperação total do paciente. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento suspeito e procurar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Dotarem, à base de Gadobenato de dimeglumina, esteve relacionado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico, sem gravidade clínica relevante, pois o paciente se recuperou completamente. A conduta adequada inclui evitar nova exposição ao agente suspeito e buscar acompanhamento especializado para esclarecimento do diagnóstico e prevenção de recorrências.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhes sobre a gravidade ou desfecho do caso, mas reações alérgicas a meios de contraste podem variar de manifestações leves, como coceira e urticária, até quadros mais graves, sendo fundamental relatar o episódio ao médico para avaliação e orientação sobre futuras exposições.

Dapagliflozin, cujo princípio ativo é a dapagliflozina, foi relacionado a um episódio de coceira, interpretado como uma reação de hipersensibilidade (alergia), classificada como clinicamente significativa e considerada grave, mas com evolução favorável, já que o paciente se recuperou totalmente. Em situações como essa, é importante comunicar o médico, pois reações alérgicas podem exigir suspensão do medicamento e monitoramento para evitar recorrências.

O medicamento Omnipaque, com princípio ativo ioexol, foi associado a uma alergia a contraste, caracterizada como reação do sistema imunitário. O caso evoluiu para recuperação completa, sugerindo que a reação foi controlada, mas é importante informar o profissional de saúde sobre o episódio, pois alergias a meios de contraste exigem precaução em exames futuros.

Gadovist, cujo princípio ativo é gadobutrol, foi relacionado a uma alergia medicamentosa, descrita como hipersensibilidade a medicamentos e classificada como distúrbio do sistema imunitário. O paciente se recuperou totalmente, indicando resolução do quadro, mas é fundamental relatar o evento ao médico para orientação sobre o uso futuro de contrastes ou medicamentos semelhantes.

O medicamento Iomeron, com princípio ativo iomeprol, foi associado a uma alergia a meios de contraste iodados, caracterizada como reação do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, mas é importante informar o médico sobre o episódio para que sejam tomadas precauções em exames futuros com contraste iodado.

O medicamento Ultrazine, cujo princípio ativo é Prochlorperazine edisylate, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há informações detalhadas sobre a gravidade ou desfecho do caso, mas, conforme as diretrizes clínicas, quadros alérgicos leves geralmente requerem observação, identificação do agente causador e, se necessário, encaminhamento ao especialista para confirmação diagnóstica e orientação sobre controle ambiental e prevenção de novas exposições.

A Dipirona monoidratada (Dipirona) foi relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, o paciente se recuperou totalmente e o medicamento não chegou a ser administrado, o que sugere que a conduta foi adequada ao evitar nova exposição e monitorar a resolução do quadro, conforme recomendações para reações leves.

O uso de Levofloxacino (Levofloxacina) resultou em uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou, indicando que a conduta de suspensão do medicamento e acompanhamento foi suficiente, em linha com as orientações para quadros leves a moderados de alergia medicamentosa.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é Gadobutrol, foi associado a uma reação alérgica ao contraste intravenoso, classificada como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou, sugerindo que a reação foi leve e manejada de acordo com as recomendações clínicas, que incluem suspensão do agente e monitoramento até resolução dos sintomas.

A vacina hepatite A, tanto nome comercial quanto princípio ativo, foi relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhes sobre gravidade ou desfecho, mas, conforme as diretrizes, quadros leves de alergia a vacinas devem ser avaliados para confirmação diagnóstica e orientação sobre riscos e benefícios de futuras doses, com acompanhamento especializado se necessário.

A vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), composta pelos vírus vivos atenuados de cada doença, foi associada a um quadro de alergia (hipersensibilidade), mas não há informação sobre a gravidade ou desfecho do caso. A reação foi classificada como distúrbio do sistema imunitário, sugerindo um evento alérgico, porém sem detalhes clínicos adicionais, não sendo possível afirmar se foi leve, moderada ou grave. Recomenda-se acompanhamento médico para avaliação da necessidade de futuras doses e investigação de alergia vacinal, conforme diretrizes da ASBAI.

A dipirona, cujo princípio ativo é a própria dipirona, foi relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando uma reação leve, compatível com quadros alérgicos transitórios. Nesses casos, é importante evitar nova exposição ao medicamento e buscar orientação médica para alternativas seguras.

O medicamento Cosentyx, que contém secuquinumabe, foi associado a lesão cutânea decorrente de hipersensibilidade, caracterizada como um distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, mas permanece não resolvido ou em andamento, sugerindo a necessidade de acompanhamento médico para monitoramento da evolução e possível ajuste do tratamento, conforme orientação especializada.

O produto Collagen, cujo princípio ativo é colágeno, foi relacionado a tontura atribuída à hipersensibilidade medicamentosa, classificada como distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o desfecho é desconhecido, o que indica que a reação pode ter sido leve, mas requer atenção para evitar nova exposição e avaliação médica caso os sintomas persistam.

O paracetamol, com princípio ativo homônimo, foi associado a tontura por hipersensibilidade medicamentosa, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Não foi considerado um caso grave e o desfecho é desconhecido, sugerindo uma reação leve, mas é importante monitorar sintomas e buscar orientação médica se houver recorrência ou agravamento.

O medicamento Dipyrrone, cujo princípio ativo é a dipirona, foi associado ao relato de tontura, considerada uma possível manifestação de hipersensibilidade medicamentosa. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave neste caso, e a reação foi classificada como não grave, sem informações adicionais sobre a evolução clínica ou conduta adotada. A tontura pode ser um sintoma leve de reação alérgica a medicamentos, e, na ausência de sinais de gravidade, recomenda-se observar o quadro e buscar avaliação médica caso haja piora ou surgimento de outros sintomas.

O medicamento Calcium 500+D, contendo cálcio e colecalciferol (vitamina D), foi relacionado ao surgimento de tontura, interpretada como possível hipersensibilidade medicamentosa. Não há registro de gravidade importante ou desfecho grave, e não foram fornecidos detalhes sobre a evolução do quadro ou medidas tomadas. A tontura, nesse contexto, sugere uma reação leve, sendo importante monitorar sintomas e procurar orientação médica se houver agravamento ou aparecimento de outros sinais de alergia.



O medicamento Puran t4, cujo princípio ativo é a levotiroxina sódica, foi associado ao relato de tontura, considerada uma possível reação de hipersensibilidade medicamentosa. Não há evidências de gravidade significativa ou desfecho grave, e não foram informadas ações específicas tomadas ou evolução do caso. A tontura, nesse contexto, sugere uma reação leve, sendo recomendada a observação dos sintomas e busca de avaliação médica caso haja piora ou aparecimento de outros sintomas alérgicos.

O medicamento Codeine, com princípio ativo codeína, foi relacionado ao surgimento de tontura, interpretada como possível manifestação de hipersensibilidade medicamentosa. Não há indicação de gravidade relevante ou desfecho grave, e não foram relatadas condutas específicas ou evolução clínica. A tontura, nesse cenário, sugere uma reação leve, sendo importante monitorar o quadro e procurar avaliação médica se houver agravamento ou surgimento de outros sintomas.

O medicamento Insit, cujo princípio ativo é pregabalina, foi associado ao relato de tontura, considerada uma possível reação de hipersensibilidade medicamentosa. Não há evidências de gravidade importante ou desfecho grave, e não foram informadas ações tomadas ou evolução do caso. A tontura, nesse contexto, sugere uma reação leve, sendo recomendada a observação dos sintomas e busca de orientação médica caso haja piora ou aparecimento de outros sinais de alergia.

O medicamento Tramadol, cujo princípio ativo também é tramadol, foi associado a um episódio de tontura classificado como hipersensibilidade medicamentosa, um tipo de reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave, e o desfecho do caso é desconhecido. A reação sugere uma resposta leve, sendo importante observar sintomas e buscar avaliação médica caso haja recorrência ou agravamento.

O medicamento Nexavar, com princípio ativo tosilato de sorafenibe, foi relacionado a tontura atribuída à hipersensibilidade medicamentosa, indicando uma possível reação alérgica do sistema imunológico. Não há registro de gravidade significativa ou desfecho grave, e o desfecho permanece desconhecido. A situação sugere uma reação leve, recomendando-se monitoramento dos sintomas e consulta médica se houver piora.

O medicamento Propantelina bromuro, cujo princípio ativo é propantheline bromide, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa, caracterizando uma hipersensibilidade do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade importante, e o paciente se recuperou totalmente após a reação. A conduta adequada inclui evitar nova exposição ao medicamento e informar profissionais de saúde sobre o episódio.

O medicamento Ibuprofeno, com princípio ativo ibuprofen, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade), evidenciando uma resposta do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade relevante, e o paciente se recuperou completamente após o evento. Recomenda-se evitar o uso futuro do ibuprofeno e comunicar o histórico de alergia em atendimentos médicos.

O medicamento Levofloxacino, cujo princípio ativo é levofloxacina, provocou hiperemia (vermelhidão), sendo documentada como hipersensibilidade ao produto administrado. O caso foi considerado clinicamente significativo, com gravidade reconhecida, mas o paciente se recuperou após a reação. É fundamental evitar o uso futuro do levofloxacino e relatar o episódio em consultas médicas para prevenir novas reações.

O medicamento Rituximab, cujo princípio ativo é o rituximabe, foi associado a um caso de perda de audição em um paciente que também apresentou sintomas de alergia ocular, classificados como manifestações oculares associadas a infecções ou inflamações. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso não foi considerado grave e o paciente encontra-se em recuperação ou em processo de resolução. A relação entre o medicamento e a reação foi considerada suspeita, e a conduta clínica deve incluir acompanhamento da evolução dos sintomas e avaliação oftalmológica, conforme necessário.

O medicamento Azorga, que contém brinzolamida e maleato de timolol como princípios ativos, foi relacionado a um episódio de perda de audição em um paciente que também apresentou sinais de alergia ocular, classificados como manifestações oculares associadas a infecções ou inflamações. O evento não foi considerado grave e o paciente está em recuperação ou resolução do quadro. A suspeita de relação com o medicamento existe, sendo importante monitorar a evolução clínica e buscar avaliação especializada se houver persistência dos sintomas.

O medicamento Mirtazapina, cujo princípio ativo é a mirtazapina, foi associado a um caso de metástases no fígado em um paciente que apresentou quadro de hipersensibilidade, classificado como reação alérgica sistêmica. O evento foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, mas o paciente evoluiu para recuperação completa. A relação com o medicamento é suspeita, sendo fundamental o acompanhamento médico rigoroso e a suspensão do uso caso a relação causal seja confirmada.

O medicamento Lexotan, com princípio ativo bromazepam, esteve relacionado a um caso de metástases no fígado em um paciente que apresentou hipersensibilidade, caracterizada como reação alérgica sistêmica. O evento foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, mas o paciente se recuperou totalmente. A suspeita de relação com o medicamento existe, sendo recomendada avaliação médica detalhada e suspensão do uso se confirmada a causalidade.

O medicamento Propranolol, cujo princípio ativo é o cloridrato de propranolol, foi associado a um caso de metástases no fígado em um paciente que apresentou hipersensibilidade, classificada como reação alérgica sistêmica. O evento foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, mas o paciente se recuperou. A relação com o medicamento é suspeita, sendo necessária avaliação médica criteriosa e interrupção do uso caso a relação causal seja confirmada.

O medicamento Vectibix, cujo princípio ativo é o panitumumabe, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), manifestado durante o tratamento de metástases no fígado. A reação foi considerada grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando a necessidade de monitoramento rigoroso e intervenção médica imediata. O paciente evoluiu para recuperação completa após a reação, indicando resolução do quadro alérgico após as medidas adotadas.

O medicamento Piperacilina - tazobactam, contendo piperacilina sódica e tazobactam sódico, foi relacionado a um episódio de dispneia (falta de ar) atribuída à hipersensibilidade, um tipo de reação alérgica que pode afetar o sistema respiratório. Não há informações detalhadas sobre a gravidade, desfecho ou necessidade de hospitalização neste caso, mas a dispneia associada ao uso do medicamento sugere a importância de avaliação médica imediata para evitar complicações.

O medicamento Cloridrato de bupivacaína + glicose, composto por cloridrato de bupivacaína e dextrose anidra, foi associado a um quadro de alergia classificado como hipersensibilidade, afetando o sistema imunológico. A reação não foi considerada grave e o paciente encontra-se em recuperação, indicando que a evolução está sendo favorável e que a conduta adotada foi suficiente para controlar o evento sem necessidade de medidas intensivas.

O medicamento Morfina, cujo princípio ativo é o sulfato de morfina, desencadeou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, envolvendo o sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o paciente está em processo de recuperação, sugerindo que a reação foi controlada adequadamente e não houve necessidade de intervenções mais complexas.

O medicamento Ocitocina, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, afetando o sistema imunológico. A reação não foi considerada grave e o paciente está em recuperação, indicando que o quadro foi manejado de forma adequada e não houve complicações maiores.

O medicamento Cefazolina, cujo princípio ativo é a cefazolina sódica, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, pois não houve necessidade de hospitalização ou complicações graves, e o paciente encontra-se em recuperação ou com resolução dos sintomas. A conduta recomendada é a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento clínico, com orientação para evitar novas exposições e buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e manejo futuro.

O Fentanil, cujo princípio ativo é o citrato de fentanila, foi relacionado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, também classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade importante, já que o paciente está em recuperação ou com sintomas resolvendo, sem relato de hospitalização ou risco à vida. Recomenda-se interromper o uso do medicamento suspeito, monitorar a evolução clínica e encaminhar para avaliação com especialista em alergia para investigação e orientação sobre futuras exposições.

O medicamento Omnipaque, cujo princípio ativo é o ioexol, foi associado a uma reação alérgica ao contraste, classificada como distúrbio do sistema imunitário. Neste caso, a gravidade é considerada alta, pois houve necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando um quadro clínico mais sério. O paciente evoluiu para recuperação completa após a conduta adequada, que inclui suspensão do agente suspeito, tratamento dos sintomas e acompanhamento médico especializado para prevenção de novas reações em futuras exposições a contrastes.

O Omnipaque, com princípio ativo ioexol, desencadeou uma reação alérgica ao contraste, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário e considerada grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação. O paciente se recuperou totalmente após a intervenção médica, que envolveu a suspensão do contraste e manejo dos sintomas, sendo fundamental o acompanhamento com especialista para evitar novas reações em procedimentos futuros.

O medicamento Omnipaque, cujo princípio ativo é o ioexol, provocou uma reação alérgica ao contraste classificada como distúrbio do sistema imunitário e considerada grave, já que foi necessária hospitalização ou prolongamento da internação. O desfecho foi favorável, com recuperação completa após a conduta médica apropriada, incluindo a suspensão do agente e tratamento dos sintomas, sendo importante o acompanhamento com alergista para orientação sobre riscos em futuras exposições a contrastes.

O medicamento Omnipaque, cujo princípio ativo é o ioexol, foi associado a um quadro de alergia a contraste, caracterizado como uma reação do sistema imunológico a substâncias químicas utilizadas em exames de imagem. A gravidade do evento é considerada alta, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando a necessidade de monitoramento e intervenção médica imediata. O paciente evoluiu para recuperação completa após a reação, e a relação causal com o medicamento é considerada suspeita.

Omnipaque, com princípio ativo ioexol, esteve relacionado a uma reação alérgica ao contraste, que é uma resposta do sistema imunológico a substâncias químicas usadas em exames radiológicos. O caso foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando que a reação exigiu cuidados médicos intensivos. O paciente se recuperou totalmente após o evento, e a suspeita de relação com o medicamento permanece.

O medicamento Omniscan, cujo princípio ativo é o gadodiamide, foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), que representa uma resposta exagerada do sistema imunológico a substâncias químicas, neste caso um contraste utilizado em exames de imagem. Não há informações detalhadas sobre a gravidade, evolução ou desfecho do caso, mas a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Adalimumab, com princípio ativo adalimumabe, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade, que é uma reação alérgica do sistema imunológico, manifestada neste contexto como outros distúrbios do intestino. Não há evidências de gravidade significativa, pois o evento não foi considerado grave, e o desfecho

permanece desconhecido. A relação com o medicamento é suspeita.

Secukinumab, cujo princípio ativo é secuquinumabe, esteve associado a um episódio de hipersensibilidade, uma reação alérgica do sistema imunológico, manifestada como outros distúrbios do intestino. O evento não foi considerado grave e o desfecho não foi informado, sendo a relação com o medicamento suspeita.

O medicamento Ceftriaxone Qualimed, cujo princípio ativo é a ceftriaxona sódica, foi associado ao surgimento de manchas cutâneas, caracterizando um quadro de hipersensibilidade (alergia) de leve intensidade, já que não há indicação de gravidade importante ou complicações clínicas no registro. O paciente se recuperou totalmente após o evento, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita, sugerindo que a conduta adequada é evitar novas exposições e monitorar possíveis reações futuras.

O Henetix, que contém o princípio ativo iobitridol, foi relacionado a um episódio de alergia a contraste, um tipo de reação imunológica que pode ocorrer após a administração de substâncias usadas em exames de imagem. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações, e o paciente se recuperou completamente, sendo a relação com o medicamento considerada suspeita; nesses casos, recomenda-se informar o paciente sobre o risco de reexposição e considerar alternativas em exames futuros.

O Omniscan, cujo princípio ativo é o gadodiamide, foi associado a uma reação de alergia a contraste, caracterizada por resposta imunológica após o uso do agente em exames. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou, sendo a relação com o medicamento suspeita; a orientação é evitar reexposição e informar a equipe de saúde sobre o histórico de alergia a contraste.

O medicamento Oxygen, que tem como princípio ativo o próprio oxigênio, foi relacionado à exacerbação de fibrose pulmonar idiopática, mas não há informações sobre gravidade relevante ou desfecho conhecido. O registro sugere suspeita de relação, mas não há detalhes suficientes para orientar conduta específica além do acompanhamento clínico atento.

O Donaren, cujo princípio ativo é o cloridrato de trazodona, foi associado à exacerbação de fibrose pulmonar idiopática, sem indicação de gravidade importante e com desfecho desconhecido. A relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo fundamental monitorar o paciente e avaliar a necessidade de ajuste terapêutico conforme evolução clínica.

O medicamento Escopolamina, cujo princípio ativo é o bromidrato de hiosciamina, foi associado a uma reação de exacerbação de fibrose pulmonar idiopática em um paciente com histórico de alergia ao leite. Embora a gravidade não tenha sido explicitamente classificada como grave e o desfecho seja desconhecido, a suspeita de envolvimento imunológico é sugerida pela categorização como distúrbio do sistema imunitário, especificamente relacionado a alergias a alimentos, aditivos e medicamentos. Não há informações suficientes sobre a conduta adotada ou a evolução clínica, sendo importante monitorar sintomas respiratórios e buscar avaliação médica caso haja piora.

O medicamento Simeticona, com princípio ativo simeticone, foi relacionado a uma exacerbação de fibrose pulmonar idiopática em um paciente que também apresenta alergia ao leite. A reação foi classificada como suspeita, sem indicação de gravidade elevada e com desfecho desconhecido. O evento está inserido no contexto de distúrbios do sistema imunitário, sugerindo possível mecanismo alérgico, mas não há detalhes sobre a conduta adotada ou evolução do quadro. Recomenda-se atenção a sintomas respiratórios e acompanhamento médico.

A Fexofenadina, cujo princípio ativo é fexofenadine, foi associada a uma exacerbação de fibrose pulmonar idiopática em paciente com alergia ao leite. O caso foi considerado suspeito, sem confirmação de gravidade importante e com desfecho não informado. A reação está relacionada a distúrbios do sistema imunitário, especialmente alergias a alimentos, aditivos e medicamentos, mas não há detalhes sobre a conduta tomada ou evolução clínica. É fundamental monitorar sintomas e buscar orientação médica se houver agravamento.

O medicamento Apresolina, com princípio ativo cloridrato de hidralazina, foi implicado em uma exacerbação de fibrose pulmonar idiopática em paciente com alergia ao leite. Não há indicação de gravidade significativa nem informações sobre o desfecho, e a reação é considerada suspeita. O evento se enquadra em distúrbios do sistema imunitário, sugerindo possível relação alérgica, mas faltam dados sobre a conduta adotada ou evolução do quadro. Recomenda-se acompanhamento clínico atento.

A Dipirona, cujo princípio ativo é dipirona, foi relacionada a uma exacerbação de fibrose pulmonar idiopática em paciente com alergia ao leite. A reação foi considerada suspeita, sem evidência de gravidade elevada e com desfecho desconhecido. O caso está inserido no contexto de distúrbios do sistema imunitário, especialmente alergias a alimentos, aditivos e medicamentos, mas não há informações sobre a conduta adotada ou evolução clínica. É importante manter vigilância dos sintomas e procurar avaliação médica se necessário.

O medicamento Domperidona (princípio ativo: Domperidone) foi associado a uma exacerbação de fibrose pulmonar idiopática, sendo também relatada alergia ao leite. A reação está relacionada a distúrbios do sistema imunitário, especificamente a alergias a alimentos, aditivos alimentares, medicamentos e outras substâncias químicas. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A conduta deve envolver avaliação clínica detalhada para investigar a possível relação entre o uso do medicamento e o agravamento do quadro pulmonar, além de considerar a história de alergia alimentar.

O medicamento Carvedilol (princípio ativo: Carvedilol) foi relacionado a uma exacerbação de fibrose pulmonar idiopática, com relato adicional de alergia ao leite. A reação envolve o sistema imunológico, especialmente no contexto de alergias a alimentos, aditivos e medicamentos. Não há evidência de gravidade importante nem desfecho informado, e a relação com o medicamento é suspeita. Recomenda-se investigação clínica para avaliar a possível ligação entre o uso do carvedilol e o agravamento da doença pulmonar, levando em conta o histórico de alergia alimentar.

O medicamento Bamifex, cujo princípio ativo é o cloridrato de bamifilina, foi associado a uma exacerbação de fibrose pulmonar idiopática e a relato de alergia ao leite. A reação está inserida no contexto de distúrbios do sistema imunitário, especialmente alergias a alimentos, aditivos e medicamentos. Não há indicação de gravidade significativa nem desfecho conhecido, sendo a relação com o medicamento considerada suspeita. É importante realizar avaliação clínica para investigar a possível relação causal e considerar o histórico de alergia alimentar.

O medicamento Quetiapina (princípio ativo: Quetiapine) foi relacionado a uma exacerbação de fibrose pulmonar idiopática, com relato de alergia ao leite. A reação envolve distúrbios do sistema imunitário, principalmente alergias a alimentos, aditivos e medicamentos. Não há evidência de gravidade relevante nem desfecho informado, e a relação com o medicamento é suspeita. Recomenda-se avaliação clínica para investigar a possível associação entre o uso da quetiapina e o agravamento do quadro pulmonar, considerando o histórico de alergia alimentar.

O medicamento Trazodona (princípio ativo: Trazodone) foi associado a uma exacerbação de fibrose pulmonar idiopática, além de relato de alergia ao leite. A reação está relacionada a distúrbios do sistema imunitário, especialmente alergias a alimentos, aditivos e medicamentos. Não há indicação de gravidade importante nem desfecho conhecido, sendo a relação com o medicamento considerada suspeita. A conduta recomendada é realizar avaliação clínica detalhada para investigar a possível relação causal e considerar o histórico de alergia alimentar.

O medicamento Espironolactona (princípio ativo: Spironolactone) foi associado à exacerbação de fibrose pulmonar idiopática, um agravamento de uma doença pulmonar crônica caracterizada por inflamação e cicatrização progressiva dos pulmões. Embora a reação tenha sido registrada como suspeita e relacionada a uma alergia ao leite, não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e não foram relatadas ações específicas adotadas. A ausência de sinais de gravidade sugere que o quadro não foi considerado grave no momento do registro.

O medicamento Mirtazapina (princípio ativo: Mirtazapine) foi relacionado a uma exacerbação de fibrose pulmonar idiopática, que é o agravamento de uma condição pulmonar crônica com inflamação e cicatrização dos pulmões. A reação foi considerada suspeita e associada a alergia ao leite, sem informações sobre gravidade significativa, desfecho ou conduta adotada, indicando que não houve evidência clínica de gravidade no registro.

O medicamento Prednisona (princípio ativo: Prednisone) foi apontado como suspeito em um caso de exacerbação de fibrose pulmonar idiopática, um agravamento de doença pulmonar crônica marcada por inflamação e fibrose progressiva. A reação foi associada a alergia ao leite, sem relato de gravidade importante, desfecho ou medidas tomadas, sugerindo que o evento não foi considerado grave no momento do registro.

O medicamento Bromazepan (princípio ativo: Bromazepam) foi relacionado a uma exacerbação de fibrose pulmonar idiopática, que consiste no agravamento de uma doença pulmonar crônica com inflamação e cicatrização dos pulmões. A reação foi considerada suspeita e associada a alergia ao leite, sem informações sobre gravidade, desfecho ou conduta, o que indica ausência de sinais clínicos de gravidade no registro.

O medicamento Venlafaxina (princípio ativo: Venlafaxine) foi associado à exacerbação de fibrose pulmonar idiopática, caracterizada pelo agravamento de uma doença pulmonar crônica com inflamação e fibrose. A reação foi registrada como suspeita e relacionada a alergia ao leite, sem relato de gravidade, desfecho ou ação adotada, sugerindo que não houve evidência de gravidade clínica relevante no momento do registro.

O medicamento Furosemida (princípio ativo: Furosemide) foi associado a uma exacerbação de fibrose pulmonar idiopática em um paciente com alergia ao leite, sendo classificado como um distúrbio do sistema imunitário relacionado a alergias a alimentos, aditivos alimentares, medicamentos e outras substâncias químicas. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sem informações adicionais sobre a conduta adotada ou evolução clínica.

A Levotiroxina sódica (princípio ativo: Levotiroxina sódica) foi relacionada a uma exacerbação de fibrose pulmonar idiopática em paciente com alergia ao leite, sendo enquadrada como distúrbio do sistema imunitário e alergia a substâncias químicas e medicamentos. Não há evidências de gravidade importante ou desfecho relatado, e a relação com o medicamento é suspeita, sem detalhes sobre a conduta ou evolução do caso.

O medicamento Pantoprazol (princípio ativo: Pantoprazol) foi associado a uma exacerbação de fibrose pulmonar idiopática em paciente com alergia ao leite, sendo classificado como distúrbio do sistema imunitário e alergia a substâncias químicas e medicamentos. Não há indicação de gravidade significativa ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sem informações sobre a conduta adotada ou evolução clínica.

Ofev (princípio ativo: Esilato de nintedanibe) foi relacionado a uma exacerbação de fibrose pulmonar idiopática em paciente com alergia ao leite, sendo categorizado como distúrbio do sistema imunitário e alergia a substâncias químicas e medicamentos. Não há evidências de gravidade relevante ou desfecho informado, e a relação com o medicamento é suspeita, sem detalhes sobre a conduta ou evolução do quadro.

O medicamento Ocitocina (princípio ativo: Ocitocina) foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário e quadro clínico alérgico, sem indicação de gravidade importante. O desfecho relatado foi de recuperação ou resolução do quadro, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sugerindo que a conduta adotada foi adequada para o controle da reação.

O medicamento Cefazolina, cujo princípio ativo é a cefazolina sódica, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente encontra-se em recuperação ou com resolução dos sintomas, e não há relato de complicações graves. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico, evitar nova exposição ao medicamento e considerar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e orientação futura.

A Morfina, com princípio ativo sulfato de morfina, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade), caracterizada por resposta imunológica adversa. O caso não foi considerado grave, já que o paciente está em recuperação ou com sintomas resolvendo, sem sinais de complicações importantes. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento, monitorar a evolução clínica e buscar avaliação especializada para esclarecimento e prevenção de novas reações.

O medicamento Cloridrato de bupivacaína + glicose, contendo cloridrato de bupivacaína e dextrose anidra como princípios ativos, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), evidenciando uma resposta do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade, pois o paciente está em recuperação ou com resolução dos sintomas, e não foram relatadas complicações. A orientação é evitar nova exposição ao medicamento, manter acompanhamento clínico e considerar avaliação com especialista para confirmação e orientação.

A Cefazolina, cujo princípio ativo é a cefazolina sódica, foi novamente associada a uma reação alérgica (hipersensibilidade), demonstrando resposta imunológica adversa. O quadro não foi considerado grave, pois o paciente está em recuperação ou com sintomas resolvendo, sem complicações relatadas. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento, monitorar a evolução clínica e buscar avaliação com alergista para esclarecimento e prevenção de novas reações.

O medicamento Ocitocina, com princípio ativo ocitocina, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), caracterizando uma resposta do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade, já que o paciente está em recuperação ou com resolução dos sintomas, sem relato de complicações. A conduta indicada é evitar nova exposição ao medicamento, manter acompanhamento clínico e considerar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação futura.

O medicamento Morfina, cujo princípio ativo é o sulfato de morfina, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), caracterizado como uma reação do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou necessidade de hospitalização, e o paciente encontra-se em recuperação ou com resolução do quadro. A conduta recomendada é observar a evolução clínica, evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Cloridrato de bupivacaína + glicose, contendo cloridrato de bupivacaína e dextrose anidra como princípios ativos, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), manifestando-se como uma reação imunológica. Não há sinais de gravidade importante ou necessidade de hospitalização, e o paciente está em recuperação ou com resolução do quadro. Recomenda-se evitar nova exposição ao medicamento, monitorar sintomas e procurar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição de alternativas seguras.

A vacina COVID-19 AstraZeneca, cujo princípio ativo é a vacina COVID-19 NRVV Ad (ChAdOx1 nCoV-19), foi associada a uma reação de alergia à vacina, manifestada por convulsão e considerada grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação. O desfecho do caso é desconhecido. Diante de reações graves após vacinação, é fundamental buscar atendimento médico imediato, relatar o evento ao serviço de saúde e seguir as orientações para investigação e manejo seguro em futuras imunizações.

O produto Amino acid, composto por diversos aminoácidos e aditivos, foi relacionado a um quadro de alergia ao leite, manifestando-se como hemangioma, uma alteração vascular que pode estar associada a reações alérgicas. Não há indicação de gravidade elevada ou necessidade de hospitalização, e o desfecho é desconhecido. Recomenda-se evitar nova exposição ao produto, monitorar sintomas e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Timolol, cujo princípio ativo é o maleato de timolol, foi associado a um quadro de alergia ao leite, manifestando-se como hemangioma, uma alteração vascular possivelmente relacionada a reações alérgicas. Não há evidência de gravidade importante ou necessidade de hospitalização, e o desfecho é desconhecido. A conduta recomendada é evitar nova exposição ao medicamento, monitorar sintomas e procurar avaliação médica para

confirmação diagnóstica e definição de alternativas seguras.

O medicamento Revitan, que contém como princípio ativo Eleutherococcus senticosus, foi associado ao surgimento de hemangioma em um paciente com histórico de alergia ao leite. A reação relatada está relacionada a distúrbios do sistema imunitário, especificamente a alergias a alimentos, aditivos alimentares, medicamentos e outras substâncias químicas. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação do medicamento com o evento é considerada suspeita. Com base nas informações disponíveis, não há evidência de gravidade clínica importante, sendo recomendada a observação e acompanhamento médico para avaliação da relação causal e evolução do quadro.

O medicamento Neutrofer, cujo princípio ativo é o ferro quelato glicinato, foi relacionado ao aparecimento de hemangioma em paciente com alergia ao leite. A reação se enquadra em distúrbios do sistema imunitário, envolvendo alergias a alimentos, aditivos alimentares, medicamentos e outras substâncias químicas. Não há sinais de gravidade significativa nem informações sobre o desfecho, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Diante disso, a conduta recomendada é o acompanhamento clínico para monitorar possíveis evoluções e avaliar a necessidade de intervenção, sem evidências de gravidade imediata.

O medicamento Ad til, que contém colecalciferol e acetato de retinol como princípios ativos, foi associado ao desenvolvimento de hemangioma em paciente com alergia ao leite. A reação está relacionada a distúrbios do sistema imunitário, especialmente alergias a alimentos, aditivos alimentares, medicamentos e outras substâncias químicas. Não há indicação de gravidade relevante nem desfecho informado, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Assim, recomenda-se acompanhamento médico para avaliação da evolução do quadro, sem necessidade de medidas emergenciais no momento.

O medicamento Omeprazole, com princípio ativo omeprazole, foi relacionado ao surgimento de hemangioma em paciente com alergia ao leite. A reação se enquadra em distúrbios do sistema imunitário, envolvendo alergias a alimentos, aditivos alimentares, medicamentos e outras substâncias químicas. Não há evidências de gravidade importante nem informações sobre o desfecho, sendo a relação com o medicamento considerada suspeita. Recomenda-se acompanhamento clínico para monitoramento do quadro e avaliação da necessidade de intervenção, sem sinais de gravidade imediata.

O medicamento Synagis, cujo princípio ativo é o palivizumabe, foi associado ao aparecimento de hemangioma em paciente com alergia ao leite. A reação está relacionada a distúrbios do sistema imunitário, especialmente alergias a alimentos, aditivos alimentares, medicamentos e outras substâncias químicas. Não há indicação de gravidade significativa nem desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Diante disso, recomenda-se acompanhamento médico para avaliação da evolução do quadro, sem necessidade de medidas urgentes no momento.

O medicamento Ceftriaxona (princípio ativo: Ceftriaxone) foi associado a um quadro de alergia, descrito como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, e o paciente encontra-se em recuperação ou com resolução do quadro. A conduta recomendada é observar sinais de alergia, evitar novas exposições ao medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas terapêuticas.

A Oxaliplatina (princípio ativo: Oxaliplatina) foi relacionada a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, classificada como clinicamente significativa e considerada grave, conforme informado. Trata-se de um distúrbio do sistema imunitário, e a gravidade é sustentada pela menção de outro efeito clinicamente relevante, o que exige atenção médica imediata, suspensão do medicamento e acompanhamento especializado para manejo da reação e prevenção de recorrências.

O medicamento Addera d3 (princípio ativo: Colecalciferol) foi associado ao aparecimento de sangue nas fezes, relacionado a uma possível alergia ao leite, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de



gravidade elevada e o desfecho é desconhecido. Recomenda-se investigar a relação entre o sintoma e o uso do medicamento, avaliar a presença de alergia alimentar e buscar orientação médica para definição do diagnóstico e conduta adequada.

O medicamento Nactali (princípio ativo: Desogestrel) foi relacionado ao sintoma de sangue nas fezes, atribuído a uma possível alergia ao leite, dentro da categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade importante e o desfecho permanece desconhecido. É indicado investigar a causa do sintoma, considerar a possibilidade de alergia alimentar e procurar avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e orientação terapêutica.

O medicamento Elani ciclo (princípios ativos: Drospirenona e Etinilestradiol) foi associado ao sintoma de sangue nas fezes, sugerindo uma possível alergia ao leite, classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade relevante e o desfecho é desconhecido. Recomenda-se avaliar a relação entre o sintoma e o uso do medicamento, investigar alergia alimentar e buscar acompanhamento médico para diagnóstico e definição do tratamento mais seguro.

O medicamento Addera d3, cujo princípio ativo é o colecalciferol, foi associado ao aparecimento de sangue nas fezes, um possível sinal de hipersensibilidade (alergia) envolvendo o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho definido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Diante desse quadro, é importante observar atentamente a evolução dos sintomas e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação adequada, especialmente se houver recorrência ou agravamento.

O medicamento Nactali, que contém desogestrel como princípio ativo, foi relacionado ao surgimento de sangue nas fezes, sugerindo uma possível reação de hipersensibilidade (alergia) mediada pelo sistema imunológico. Não há evidências de gravidade importante ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Recomenda-se acompanhamento clínico para monitorar a evolução dos sintomas e avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e conduta apropriada.

O medicamento Elani ciclo, composto por drospirenona e etinilestradiol, foi associado ao relato de sangue nas fezes, indicando uma possível reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade significativa ou desfecho, e a relação com o medicamento é suspeita. É fundamental observar a evolução clínica e procurar orientação médica para investigação e definição da melhor conduta, principalmente se houver persistência ou piora dos sintomas.

O medicamento Ceftriaxona, cujo princípio ativo é a ceftriaxona, foi relacionado ao desenvolvimento de alergia, caracterizada como hipersensibilidade do sistema imunológico. O caso não apresenta sinais de gravidade importante e está em recuperação ou resolução, com suspeita de relação com o medicamento. A conduta adequada inclui acompanhamento clínico para garantir a resolução completa dos sintomas e evitar reexposição ao agente suspeito.

O medicamento Amitriptilina, com princípio ativo cloridrato de amitriptilina, foi associado ao surgimento de alergia, caracterizada como hipersensibilidade do sistema imunológico. Não há indícios de gravidade relevante e o quadro está em recuperação ou resolução, sendo a relação com o medicamento considerada suspeita. Recomenda-se acompanhamento médico para monitorar a evolução e evitar nova exposição ao medicamento caso a relação causal seja confirmada.

O medicamento Bio manguinhos infliximabe, cujo princípio ativo é o infliximabe, foi associado a palpitação, interpretada como uma reação de hipersensibilidade (alergia) relacionada ao sistema imunológico. Não há informação sobre gravidade clínica relevante ou desfecho do caso, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Recomenda-se acompanhamento clínico para avaliar a necessidade de intervenção, conforme diretrizes para quadros alérgicos leves.

O colírio midríático, composto por sulfato de atropina, bromidrato de hiosciamina e cloridrato de fenilefrina, foi relacionado a um episódio de alergia documentada ao medicamento administrado, caracterizando uma hipersensibilidade comprovada ao produto. Não há detalhes sobre gravidade, desfecho ou evolução clínica, mas a relação com o medicamento é suspeita. Em casos assim, é fundamental evitar reexposição e buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação futura.

A clindamicina (fosfato de clindamicina) foi associada a uma reação alérgica espontânea, descrita como atopia, que resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, indicando gravidade clínica significativa. O paciente se recuperou totalmente após o evento, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Em situações de alergia grave com necessidade de hospitalização, recomenda-se suspensão imediata do medicamento, tratamento sintomático e acompanhamento especializado para evitar novas exposições.

O hipoclorito de sódio foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade) classificado como clinicamente significativo, com gravidade reconhecida e desfecho de recuperação completa. A relação com o produto é suspeita. Em casos de reações alérgicas relevantes, é importante interromper o contato com o agente, tratar os sintomas e realizar acompanhamento médico para evitar recorrências.

A ceftriaxona (ceftriaxona sódica) foi associada a uma alergia medicamentosa (hipersensibilidade), caracterizada como reação do sistema imunológico a medicamentos. Não há detalhes sobre gravidade, mas o paciente está em recuperação. A relação com o medicamento é suspeita. Nestes casos, recomenda-se evitar novas exposições ao fármaco e manter acompanhamento clínico até resolução completa dos sintomas.

O medicamento Henetix, que contém os princípios ativos lobitridol, Sodium calcium edetate, Trometamol e Cloridrato de trometamol, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado por uma reação do sistema imunológico a substâncias químicas presentes no medicamento. Não há informações detalhadas sobre a gravidade ou desfecho do caso, portanto recomenda-se atenção clínica para sinais de alergia e acompanhamento médico para avaliação e conduta adequada.

O medicamento Artrinid, cujo princípio ativo é o Cetoprofeno, foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), que corresponde a uma reação do sistema imunológico a medicamentos. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando que a reação foi leve e resolvida sem complicações, sendo importante evitar nova exposição ao medicamento e informar o médico sobre o histórico de alergia.

O medicamento Vectibix, que tem como princípio ativo o Panitumumabe, foi associado a retenção de líquido em um contexto de hipersensibilidade, o que sugere uma reação alérgica do sistema imunológico. O caso não foi considerado grave e o paciente está em recuperação, indicando que a reação foi moderada e está evoluindo positivamente, sendo fundamental o acompanhamento médico para monitorar a resolução completa dos sintomas.

O medicamento Cefepim, cujo princípio ativo é o Cefepime, foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizando uma reação do sistema imunológico ao antibiótico. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, sugerindo que a reação foi leve e resolvida sem complicações, sendo importante evitar o uso futuro do medicamento e comunicar o histórico ao profissional de saúde.

O medicamento Cefepim, com princípio ativo Cefepime, esteve envolvido em um caso de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), indicando uma resposta do sistema imunológico ao antibiótico. O episódio não foi considerado grave e o paciente está em recuperação, o que sugere uma reação moderada em evolução favorável, sendo recomendada a continuidade do acompanhamento médico até a resolução completa dos sintomas.

O medicamento Cefepime, cujo princípio ativo também é cefepime, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade). Não há descrição de sintomas graves ou complicações, e o registro indica que a reação não foi considerada grave. A manifestação se enquadra como uma resposta do sistema imunológico ao medicamento, sendo importante relatar o episódio ao médico para avaliação e orientação sobre o uso futuro de cefalosporinas ou antibióticos relacionados.

O medicamento Propilracil, com princípio ativo propiltiouracila, foi relacionado à ineficácia terapêutica em um paciente com histórico de alergias múltiplas. Não há menção de sintomas alérgicos específicos ou gravidade associada, e o desfecho foi de recuperação completa. A situação sugere que o medicamento não atingiu o efeito esperado, sendo importante discutir alternativas terapêuticas com o médico, especialmente em pacientes com histórico de reações alérgicas.

O medicamento Tapazol, que deveria ter como princípio ativo metimazol, mas foi registrado como cetoconazol, foi associado à ineficácia do tratamento em um paciente com alergias múltiplas. Não há relato de sintomas alérgicos ou complicações graves, e o desfecho foi de resolução do quadro. É fundamental revisar a prescrição e confirmar o princípio ativo correto, além de considerar alternativas em casos de resposta inadequada ao tratamento.

O medicamento Henetix, composto por iobitridol, sodium calcium edetate, trometamol e cloridrato de trometamol, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), sem descrição de sintomas graves e com recuperação completa do paciente. A reação foi considerada não grave, indicando que o quadro foi controlado sem complicações, mas é importante informar o médico sobre o episódio para evitar futuras exposições a contrastes ou substâncias semelhantes.

O medicamento Tramadol, cujo princípio ativo é tramadol, foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), sem relato de sintomas graves e com resolução completa do quadro. Não há evidências de gravidade ou complicações, mas é fundamental comunicar o médico sobre a reação para avaliar a necessidade de evitar o uso futuro deste analgésico ou de outros medicamentos da mesma classe.

O medicamento Amicacina, cujo princípio ativo é o sulfato de amicacina, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, sem detalhamento de sintomas específicos. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente. A conduta recomendada em situações de hipersensibilidade leve é observar o paciente, evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas terapêuticas.

O Cetoprofeno, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a uma reação de alergia espontânea descrita como atopia, que é uma predisposição genética a desenvolver alergias. Não há relato de sintomas graves ou complicações, e o paciente se recuperou completamente. Em casos leves de manifestações alérgicas, recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e procurar orientação médica para avaliação e controle dos sintomas.

O medicamento Sulfato de Amicacina, com o mesmo princípio ativo, foi associado a um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, sem detalhamento de sintomas. O caso não foi considerado grave e o paciente está em processo de recuperação. Em situações de hipersensibilidade leve, a recomendação é suspender o uso do medicamento, monitorar a evolução clínica e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição de alternativas seguras.

A Cefazolina, cujo princípio ativo é cefazolin, foi relacionada a uma reação de alergia a antibiótico, tecnicamente chamada de hipersensibilidade medicamentosa. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, mas o paciente se recuperou totalmente. Em casos de alergia grave a antibióticos, é fundamental suspender imediatamente o medicamento, realizar avaliação médica urgente e registrar a alergia para evitar futuras exposições, seguindo as orientações de um especialista.

O medicamento Vit D, com princípio ativo ergocalciferol, foi associado a um quadro de pneumonia descrito como hipersensibilidade, mas não há detalhes sobre sintomas específicos ou relação causal clara. O caso não foi considerado grave, porém o paciente ainda não se recuperou. Diante de eventos adversos não graves, recomenda-se suspender o uso do medicamento suspeito, monitorar a evolução clínica e buscar avaliação médica para investigação adequada.

O medicamento Vitamin C, cujo princípio ativo é o ácido ascórbico, foi associado a um quadro de pneumonia relacionado à hipersensibilidade (reação alérgica), classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois não foi relatado como grave, e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento. A reação sugere um possível envolvimento alérgico, mas não há detalhes sobre a conduta adotada ou evolução clínica além do acompanhamento do caso.

O Folifer, contendo sulfato ferroso e ácido fólico como princípios ativos, foi relacionado a um episódio de pneumonia atribuída à hipersensibilidade (reação alérgica), enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa, já que não foi classificado como grave, e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento. A descrição sugere uma possível reação alérgica, mas não há informações adicionais sobre a conduta tomada ou evolução clínica.

O medicamento Prolia, cujo princípio ativo é o denosumabe, foi associado a um caso de pneumonia atribuída à hipersensibilidade (reação alérgica), categorizada como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade aumentada, pois não foi considerado grave, e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento. A reação sugere envolvimento alérgico, mas não há detalhes sobre a conduta adotada ou evolução clínica além do acompanhamento do caso.

O Fulvestrant, com princípio ativo fulvestranto, foi relacionado a um quadro de pneumonia decorrente de hipersensibilidade (reação alérgica), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade relevante, já que não foi considerado grave, e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento. A descrição sugere uma possível reação alérgica, sem informações adicionais sobre a conduta adotada ou evolução clínica.

O Exodus, cujo princípio ativo é o oxalato de escitalopram, foi associado a um episódio de pneumonia atribuída à hipersensibilidade (reação alérgica), enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade aumentada, pois não foi relatado como grave, e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento. A reação sugere envolvimento alérgico, mas não há detalhes sobre a conduta adotada ou evolução clínica além do acompanhamento do caso.

O medicamento Epez, cujo princípio ativo é o cloridrato de donepezila, foi associado a um quadro de pneumonia relacionado à hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois não há menção de desfecho grave ou complicações críticas, e o evento permanece em andamento, sem resolução até o momento. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico, avaliar a necessidade de suspensão do medicamento e monitorar a evolução do quadro, buscando orientação médica especializada para confirmação diagnóstica e definição do melhor manejo.

O medicamento Kisqali, com princípio ativo succinato de ribociclib, apresentou relato de pneumonia atribuída a hipersensibilidade, sugerindo uma reação alérgica do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade importante, já que o evento não foi classificado como grave e permanece sem resolução. Recomenda-se acompanhamento médico para monitoramento do quadro, avaliação da relação causal com o medicamento e definição de conduta, incluindo possível suspensão e investigação de outras causas.

No caso do medicamento Vit D, cujo princípio ativo é o ergocalciferol, houve relato de pneumonia associada a hipersensibilidade, indicando uma reação alérgica do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e já está resolvido, com recuperação completa do paciente. A conduta adequada inclui observação clínica e

reavaliação da necessidade de reexposição ao medicamento, além de orientação para evitar uso indiscriminado caso haja recorrência de sintomas.

O medicamento Vitamin C, com princípio ativo ácido ascórbico, foi relacionado a um episódio de pneumonia por hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunitário. O quadro não foi considerado grave e o paciente já se encontra recuperado. Recomenda-se acompanhamento clínico e orientação para evitar nova exposição ao medicamento caso sintomas semelhantes voltem a ocorrer.

O medicamento Folifer, composto por sulfato ferroso e ácido fólico, esteve associado a um episódio de pneumonia por hipersensibilidade, indicando uma reação alérgica do sistema imunitário. O evento não foi classificado como grave e o paciente já está recuperado. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico e considerar alternativas terapêuticas caso haja necessidade de reposição de ferro ou ácido fólico, evitando reexposição se houver suspeita de alergia confirmada.

O medicamento Prolia, cujo princípio ativo é o denosumabe, foi associado a um quadro de pneumonia relacionado a hipersensibilidade, caracterizado como um distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta adotada foi adequada, resultando em resolução completa do quadro, o que sugere que a reação foi controlada sem complicações maiores.

O medicamento Fulvestrant, com princípio ativo fulvestranto, esteve relacionado a um episódio de pneumonia por hipersensibilidade, enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação total, indicando que a reação foi leve e manejada de forma eficaz, sem consequências duradouras.

O medicamento Exodus, cujo princípio ativo é o oxalato de escitalopram, foi associado a um caso de pneumonia decorrente de hipersensibilidade, classificado como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente, demonstrando que a reação foi leve e controlada adequadamente.

O medicamento Epez, com princípio ativo cloridrato de donepezila, esteve envolvido em um episódio de pneumonia por hipersensibilidade, categorizado como distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando que a reação foi leve e bem manejada, sem complicações.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é o succinato de ribociclibe, foi relacionado a um quadro de pneumonia por hipersensibilidade, classificado como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa, sugerindo que a reação foi leve e adequadamente controlada.

O medicamento Ceftriazona (princípio ativo Ceftriaxone) foi associado a um quadro de alergia, caracterizado como hipersensibilidade, que se enquadra nos distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade, mas o desfecho informado foi de recuperação completa, sugerindo que a reação foi controlada e resolvida sem complicações maiores.

O medicamento Xolair (princípio ativo Omalizumabe) foi relacionado a um episódio de falta de ar, interpretado como manifestação de hipersensibilidade (alergia), dentro do contexto de distúrbios do sistema imunitário. Não há relato de gravidade significativa e o evento não foi considerado grave, mas o desfecho permanece desconhecido, indicando que não há informação sobre a evolução clínica após a reação.

O medicamento Henetix (princípio ativo lobitridol) foi associado a um quadro de alergia, descrito como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhes sobre sintomas, gravidade ou evolução clínica, impossibilitando uma avaliação mais precisa da gravidade ou da conduta adotada.

O medicamento Ultravist (princípio ativo Iopromide) foi relacionado a um episódio de alergia, classificado como hipersensibilidade e enquadrado nos distúrbios do sistema imunitário. Não foram fornecidas informações sobre sintomas específicos, gravidade ou desfecho, o que limita a análise sobre a evolução do caso e as medidas tomadas.

O medicamento Morfina (princípio ativo Morfina) foi associado a um quadro de alergia, caracterizado como hipersensibilidade e pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando que a reação foi controlada de forma adequada e sem consequências duradouras.

O medicamento Tramadol, cujo princípio ativo também é tramadol, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o evento foi classificado como não grave e o paciente já se encontra recuperado ou resolvido. A conduta adequada nesses casos é a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento clínico para evitar novas exposições, sendo importante relatar o episódio ao médico para avaliação de alternativas seguras.

No caso da Dipirona sódica, com princípio ativo dipirona, houve relato de alergia a medicamentos alopáticos, descrita como hipersensibilidade medicamentosa, dentro do grupo de distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou evolução clínica, mas o medicamento não chegou a ser administrado, o que sugere que a suspeita de alergia foi considerada previamente e evitou-se a exposição. Nesses casos, é fundamental manter a restrição ao medicamento e buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento AAS, cujo princípio ativo é o ácido acetilsalicílico, foi relacionado a um quadro de bacteremia, mas a descrição técnica indica hipersensibilidade, enquadrando-se em distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente está em recuperação ou resolvendo, sugerindo evolução favorável. A conduta recomendada é a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento médico para monitorar a resolução dos sintomas e evitar novas exposições.

A Sinvastatina, com princípio ativo sinvastatina, foi associada a um quadro de bacteremia, mas a categorização técnica aponta para hipersensibilidade, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente está em recuperação ou resolvendo, indicando que a evolução clínica é positiva. Recomenda-se a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento médico para garantir a resolução completa dos sintomas e prevenir recorrências.

O medicamento Atenolol, cujo princípio ativo também é atenolol, foi relacionado a um quadro de bacteremia, mas a classificação técnica indica hipersensibilidade, pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente está em recuperação ou resolvendo, o que sugere boa evolução clínica. A conduta adequada é suspender o uso do medicamento suspeito e manter acompanhamento médico para monitorar a resolução dos sintomas e evitar novas exposições.

O medicamento Vectibix, cujo princípio ativo é o panitumumabe, foi associado a um quadro de bacteremia acompanhado de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do tipo imunológica. Apesar de não haver indicação de gravidade elevada, o paciente encontra-se em recuperação, sugerindo que a conduta adotada foi adequada para o controle do evento. A relação do medicamento com a reação foi considerada suspeita.

O medicamento Ultravist, com princípio ativo Iopromida, esteve relacionado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), manifestando-se como uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade importante e o paciente já se encontra recuperado, indicando resolução completa do quadro. O medicamento foi considerado suspeito na origem da reação.

A insulina asparta, cujo princípio ativo é insulina asparte, foi associada a um quadro de alergia (hipersensibilidade) classificado como clinicamente significativo, o que indica gravidade aumentada. O desfecho do caso é desconhecido, mas a relação com o medicamento foi considerada suspeita, sendo importante acompanhamento médico para avaliação e manejo adequado.

O medicamento Ultravist, com princípio ativo iopromida, esteve envolvido em uma reação de alergia (hipersensibilidade), mas não há informações suficientes sobre gravidade, desfecho ou conduta adotada. A relação foi considerada como interação, sugerindo possível envolvimento com outros fatores ou medicamentos.

O medicamento Cosentyx, cujo princípio ativo é secuquinumabe, foi relacionado a uma lesão de raiz de nervo acompanhada de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade relevante e o paciente já se encontra recuperado, indicando resolução do evento. O medicamento foi considerado suspeito na origem da reação.

O medicamento Dexametasona, cujo princípio ativo é o fosfato de dexametasona, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, manifestação comum de reações alérgicas a medicamentos. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso está em recuperação e não foi considerado grave, sugerindo um quadro leve de alergia medicamentosa. A conduta recomendada é observar a evolução dos sintomas, evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas terapêuticas.

O Cetoprofeno, com princípio ativo de mesmo nome, desencadeou uma reação de alergia do tipo hipersensibilidade, que se enquadra em quadros clínicos alérgicos leves, já que não houve gravidade relatada e o paciente está em recuperação. A orientação é suspender o uso do medicamento, monitorar os sintomas e procurar avaliação médica para confirmação da alergia e definição de alternativas seguras.

O medicamento Niquitin, cujo princípio ativo é a nicotina, foi relacionado a um episódio de alergia do tipo hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica leve, pois não houve gravidade e o desfecho foi de recuperação completa. Recomenda-se evitar nova exposição ao produto e buscar orientação médica para avaliação de alternativas para cessação do tabagismo.

O Ultravist, com princípio ativo iopromida, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) durante seu uso, classificada como leve devido à ausência de gravidade e à resolução completa do quadro. A conduta adequada é evitar futuras exposições ao contraste e informar a equipe médica sobre o episódio em exames futuros.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é iopromida, provocou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, considerada leve, pois não houve gravidade e o paciente se recuperou totalmente. Recomenda-se evitar o uso futuro deste contraste e comunicar o histórico de alergia em procedimentos médicos subsequentes.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do sistema imunológico. A descrição clínica sugere um quadro leve, pois não há indicação de gravidade aumentada, o paciente se recuperou totalmente e não houve complicações. A conduta recomendada nesses casos é observar o paciente, evitar novas exposições ao agente suspeito e, se necessário, buscar avaliação com especialista para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições.

O Gadovist, com princípio ativo gadobutrol, foi relacionado a uma reação alérgica inespecífica (hipersensibilidade), sem sinais de gravidade ou complicações, já que o paciente se recuperou completamente. O quadro sugere uma manifestação leve de alergia, sendo importante evitar novas exposições ao medicamento e considerar avaliação com alergista para esclarecimento diagnóstico e orientação adequada.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade), manifestando-se como resposta do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade aumentada, pois o paciente se recuperou sem intercorrências, indicando um quadro leve. Recomenda-se evitar novas exposições ao agente suspeito e buscar avaliação especializada para confirmação e orientação sobre futuras administrações.

O Ultravist, com princípio ativo iopromide, esteve relacionado a uma reação alérgica inespecífica (hipersensibilidade), sem sinais de gravidade, já que o paciente se recuperou totalmente. Trata-se de um quadro leve, sendo importante evitar novas exposições ao medicamento e considerar avaliação com alergista para esclarecimento diagnóstico e conduta futura.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, foi associado a uma reação alérgica inespecífica (hipersensibilidade), sem indícios de gravidade, pois o paciente se recuperou completamente. O quadro é considerado leve, recomendando-se evitar novas exposições ao agente e buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação adequada.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações, e não foram relatados desfechos ou necessidade de intervenção específica, sugerindo um quadro leve e autolimitado, compatível com reações alérgicas leves a agentes de contraste, conforme as diretrizes clínicas.

O Ultravist, que contém iopromida como princípio ativo, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação imunológica. O caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando que a reação foi leve e autolimitada, sem necessidade de medidas emergenciais, em linha com o manejo recomendado para quadros alérgicos leves a contrastes iodados.

O Gadovist, com gadobutrol como princípio ativo, esteve envolvido em uma reação alérgica (hipersensibilidade) do tipo leve, sem sinais de gravidade ou complicações. O paciente evoluiu para recuperação completa, o que reforça o caráter benigno do evento e a ausência de necessidade de intervenções além da observação clínica, conforme orientações para reações alérgicas leves a agentes de contraste.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é a iopromida, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) leve, sem evidências de gravidade ou complicações clínicas. Não há informações sobre o desfecho, mas a ausência de sinais de gravidade sugere que o quadro foi autolimitado, compatível com reações leves a contrastes iodados, conforme recomendações clínicas.

O Ultravist, com iopromida como princípio ativo, esteve relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade) leve, sem indicação de gravidade ou complicações. O paciente se recuperou totalmente, o que indica que a reação foi autolimitada e não exigiu intervenções além da observação, em conformidade com o manejo recomendado para reações alérgicas leves a agentes de contraste.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), manifestando-se como uma reação alérgica significativa do tipo SOE (sistema orgânico envolvido não especificado). A gravidade do evento foi considerada clinicamente relevante, pois foi classificada como outro efeito clinicamente significativo, o que indica necessidade de atenção médica imediata. O paciente se recuperou totalmente após a reação, e a relação causal com o medicamento foi considerada suspeita.

O medicamento Diovan, que contém valsartana como princípio ativo, foi relacionado a um caso de hipersensibilidade medicamentosa, manifestando-se como glaucoma. Embora a reação tenha sido considerada não grave, a relação com o medicamento foi considerada suspeita e o desfecho permanece desconhecido, sendo importante monitorar o paciente para possíveis evoluções.



O medicamento Simbrinza, composto por tartarato de brimonidina e brinzolamida, foi associado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, também manifestando-se como glaucoma. A reação não foi considerada grave, a relação com o medicamento é suspeita e o desfecho não foi informado, sendo recomendada a observação clínica para acompanhamento.

O medicamento Ultravist, com princípio ativo iopromide, esteve envolvido em um caso de hipersensibilidade (alergia), caracterizado por sintomas alérgicos gerais. Não há informação sobre gravidade, mas o paciente se recuperou totalmente após o evento, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita.

O medicamento Henetix, que contém iobitridol, sodium calcium edetate, trometamol e cloridrato de trometamol como princípios ativos, foi associado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), manifestando-se por sintomas alérgicos gerais. Não há informação sobre gravidade, mas o paciente se recuperou totalmente após a reação, e a relação causal com o medicamento foi considerada suspeita.

O medicamento Butylscopolamine bromide (Butilbrometo de escopolamina) foi associado a um quadro de alergia, caracterizado como hipersensibilidade, sem indicação de gravidade importante ou complicações graves, já que o paciente se recuperou totalmente. A reação foi considerada leve, compatível com manifestações alérgicas comuns, e não houve necessidade de intervenções emergenciais, sendo o desfecho favorável.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o Iopromide, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade), sem sinais de gravidade ou complicações sérias, pois o paciente se recuperou completamente. O quadro foi leve, típico de reações alérgicas a medicamentos, e não exigiu medidas de urgência, com resolução espontânea.

O medicamento Ultravist (Iopromide) provocou uma erupção cutânea, identificada como alergia a contraste, sem sinais de gravidade ou evolução para quadros mais sérios, embora o desfecho não tenha sido informado. Trata-se de uma reação alérgica leve, comum após exposição a contrastes, e não há evidências de complicações relevantes neste caso.

O medicamento Fluarix quadrivalent, que contém vacina influenza inativada fragmentada 4v, foi relacionado a uma alergia documentada ao produto administrado, caracterizada como hipersensibilidade, mas não há informações sobre gravidade, evolução ou desfecho. A ausência de dados adicionais impede uma avaliação mais detalhada da gravidade ou da conduta adotada.

O medicamento Clindamicina (Fosfato de clindamicina) foi associado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, sem sinais de gravidade ou complicações, já que o paciente se recuperou totalmente. O quadro foi leve, compatível com manifestações alérgicas comuns, e não houve necessidade de intervenções emergenciais, com desfecho favorável.

O medicamento Dipirona, cujo princípio ativo também é Dipirona, foi associado a um episódio de alergia documentada após administração, caracterizada como hipersensibilidade ao produto. A reação foi classificada como um erro ou problema relacionado ao monitoramento do produto, dentro do contexto de lesões e complicações de procedimentos. Não há informação detalhada sobre a gravidade, mas o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente após a suspensão do medicamento.

A Dipirona, com princípio ativo Metamizol de magnésio, provocou uma reação alérgica (hipersensibilidade) considerada clinicamente significativa, evidenciada pela classificação de gravidade e confirmação de gravidade relevante. O quadro se enquadra em distúrbios do sistema imunitário, manifestando-se como um quadro clínico alérgico. O paciente se recuperou totalmente após a conduta adequada, que incluiu a interrupção do medicamento suspeito.

O medicamento Metoclopramida, cujo princípio ativo é Metoclopramide, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), mas não chegou a ser administrado ao paciente. Não há informações sobre gravidade,

evolução clínica ou desfecho, pois a reação foi apenas suspeitada e o medicamento não foi utilizado.

O Gadovist, com princípio ativo Gadobutrol, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) após administração, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave e o paciente apresentou recuperação completa após a conduta adequada, que incluiu a suspensão do agente suspeito.

O medicamento Prohance, que contém os princípios ativos Calteridol calcium, Gadoteridol e Trometamol, foi relacionado a um episódio de alergia a contraste intravenoso, classificado como alergia a medicamentos e outras substâncias químicas. A reação não foi considerada grave e o paciente se recuperou totalmente após a suspensão do contraste, sem complicações adicionais.

O medicamento Avamys, cujo princípio ativo é o Fluticasone Furoate, foi associado a um episódio de inchaço, caracterizado como hipersensibilidade medicamentosa (reação alérgica). A reação foi classificada como não grave, pois não há indicação de complicações sistêmicas ou risco imediato à vida, e o desfecho foi de recuperação completa. Em situações como essa, recomenda-se suspender o uso do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação da alergia e orientação sobre alternativas terapêuticas.

O Esalerg, que contém Desloratadine como princípio ativo, desencadeou um quadro de inchaço relacionado à hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica ao medicamento. Não houve sinais de gravidade, já que o paciente se recuperou totalmente e não foram relatadas complicações. Nesses casos, é importante interromper o uso do medicamento suspeito e procurar orientação médica para avaliação e definição do tratamento mais seguro.

O medicamento Novocilin, cujo princípio ativo é Amoxicilina trihidrato, provocou um episódio de inchaço, caracterizando uma reação de hipersensibilidade medicamentosa (alergia ao medicamento). A reação não foi considerada grave, pois não houve evolução para quadros sistêmicos ou risco à vida, e o paciente se recuperou completamente. A conduta recomendada é suspender o uso do antibiótico e buscar avaliação médica para confirmação da alergia e orientação sobre alternativas seguras.

O Optiray 320, que tem como princípio ativo o Ioversol, foi relacionado a um episódio de alergia, classificado como hipersensibilidade. A reação não foi considerada grave, pois não houve complicações relatadas e o paciente se recuperou totalmente. Em casos de alergia a contraste iodado, é fundamental informar a equipe médica em futuras exposições e considerar alternativas ou medidas preventivas em exames subsequentes.

O medicamento Henetix, composto por Iobitridol, Sodium calcium edetate, Trometamol e Cloridrato de trometamol, foi associado a um episódio de alergia, caracterizado como hipersensibilidade. Não houve sinais de gravidade, já que o paciente se recuperou completamente. Em situações de alergia a contraste, recomenda-se informar a equipe médica em exames futuros e discutir estratégias de prevenção ou alternativas seguras.

O medicamento Optiray 320, cujo princípio ativo é o Ioversol, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do sistema imunológico a um agente externo. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi resolvido com recuperação completa do paciente. A conduta recomendada, conforme diretrizes clínicas, inclui a suspensão do agente suspeito e acompanhamento para evitar novas exposições, sendo importante relatar o episódio ao médico para futuras avaliações de risco.

O Iomeron, que contém o princípio ativo Iomeprol, foi relacionado a uma alergia a meios de contraste iodados, uma reação imunológica que pode ocorrer após a administração desse tipo de substância. Não há menção de gravidade significativa e o paciente se recuperou totalmente. A orientação clínica é evitar novas exposições ao contraste iodado e informar profissionais de saúde sobre o episódio para prevenir recorrências.

A dipirona, com princípio ativo de mesmo nome, provocou uma alergia documentada após administração, caracterizando uma hipersensibilidade ao medicamento. Não há detalhes sobre a gravidade ou evolução do caso,

mas a documentação da reação sugere a necessidade de evitar o uso futuro do fármaco e comunicar o histórico ao médico para garantir segurança em tratamentos posteriores.

O medicamento Vectibix, cujo princípio ativo é o panitumumabe, foi associado ao surgimento de acne pustulosa, interpretada como uma manifestação de hipersensibilidade medicamentosa. O caso não foi considerado grave e permanece em andamento, sem resolução até o momento. A conduta clínica envolve monitoramento contínuo e avaliação médica para manejo dos sintomas e decisão sobre a continuidade do tratamento.

O Henetix, que tem como princípio ativo o iobitridol, foi relacionado a uma alergia ocular, caracterizada por sintomas de inflamação ou desconforto nos olhos após o uso do medicamento. O episódio não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente. Recomenda-se evitar nova exposição ao agente e informar o médico sobre o ocorrido para orientar futuras condutas.

O medicamento Piperacilina - tazobactam, que contém os princípios ativos piperacilina sódica e tazobactam sódico, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade). A reação foi classificada como relacionada a distúrbios do sistema imunitário, mas não há indicação de gravidade elevada, já que o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada, conforme diretrizes clínicas, é evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas terapêuticas seguras.

O contraste Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, foi relacionado a um episódio de alergia a contraste, caracterizado como uma reação do sistema imunitário. Não há menção de sintomas graves ou complicações, e o paciente se recuperou completamente. Em situações como essa, recomenda-se evitar o uso futuro do mesmo contraste e realizar avaliação com alergista para investigação de possíveis fatores de risco e definição de estratégias seguras para exames futuros.

A Oxaliplatina, utilizada como princípio ativo, foi associada a um quadro de alergia (hipersensibilidade), enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. Não há relato de gravidade significativa, pois o paciente evoluiu para recuperação completa. Diante desse tipo de reação, é importante suspender o uso do medicamento e encaminhar para avaliação especializada, visando confirmar o diagnóstico e discutir alternativas terapêuticas seguras.

O medicamento Puravit a/d/e, que contém retinol, tocoferol e vitamina D, foi relacionado a um episódio de sangramento intestinal, mas a descrição técnica sugere possível associação com alergia ao leite. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou evolução clínica. Em casos suspeitos de alergia alimentar associada a medicamentos, recomenda-se investigação detalhada para confirmação do diagnóstico e orientação sobre substituição do produto, além de acompanhamento médico para monitorar possíveis complicações.

O medicamento Oxalato de escitalopram, com o mesmo princípio ativo, foi associado a um quadro de sangramento intestinal, sendo tecnicamente relacionado à alergia ao leite, embora não haja detalhes clínicos adicionais. Não há informações sobre gravidade ou desfecho. Diante de suspeita de reação adversa com possível componente alérgico, é fundamental buscar avaliação médica para esclarecimento diagnóstico, suspensão do medicamento se indicado e definição de alternativas seguras.

O medicamento Trimbow, que contém os princípios ativos dipropionato de beclometasona, fumarato de formoterol e brometo de glicopirrônio, é conhecido comercialmente como Trimbow, mas também pode ser encontrado sob outras marcas em alguns países, como Foster e Fostair. Neste caso, foi relatado um episódio de ataque asmático, ou seja, uma crise de falta de ar, chiado e aperto no peito (crise de asma), após o uso do medicamento. O registro não apresenta critérios de alta severidade, indicando que o quadro não foi grave e o paciente se recuperou totalmente. Este evento se enquadra como uma reação respiratória, tecnicamente classificada como um quadro clínico alérgico nos distúrbios do sistema imunitário. Recomenda-se manter acompanhamento médico regular, identificar possíveis gatilhos ambientais e revisar o plano de controle da asma conforme as orientações da ASBAI.

Fique atento a sinais de alerta como piora súbita da falta de ar, chiado intenso, dificuldade para falar ou cianose (lábios ou unhas arroxeados), e procure atendimento médico imediato caso esses sintomas ocorram.

O medicamento Fasenra, cujo princípio ativo é o benralizumabe, foi associado a um ataque asmático classificado como reação de hipersensibilidade (alergia), pertencente ao grupo de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada, conforme diretrizes clínicas, é manter acompanhamento médico para controle da asma e evitar exposição a possíveis desencadeantes, reforçando que o uso do medicamento deve ser supervisionado por especialista.

A cefazolina sódica (Cefazolina sodica) foi relacionada a um episódio de alergia caracterizado como hipersensibilidade, enquadrado entre quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade importante, já que o paciente se recuperou completamente. Recomenda-se evitar novas exposições ao medicamento e buscar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O diclofenaco (princípio ativo: diclofenaco potássico ou diclofenaco de potássio) foi associado a uma alergia medicamentosa, definida tecnicamente como hipersensibilidade medicamentosa, dentro do grupo de alergias a medicamentos e distúrbios do sistema imunitário. O paciente evoluiu para recuperação total, sem indicação de gravidade relevante. A orientação é evitar o uso futuro do diclofenaco e consultar um especialista para avaliação de alternativas e confirmação da alergia.

A dipirona monoidratada (princípio ativo: dipirona) foi relacionada a um quadro de alergia, classificado como hipersensibilidade e pertencente ao grupo de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. O paciente se recuperou totalmente, sem sinais de gravidade. Recomenda-se não utilizar novamente a dipirona e procurar avaliação com alergista para esclarecimento diagnóstico e orientação sobre medicamentos alternativos.

O medicamento Eposido, cujo princípio ativo é o etoposídeo, foi associado a um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, enquadrado entre quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade significativa, pois o paciente se recuperou completamente. A conduta indicada é evitar nova exposição ao etoposídeo e buscar avaliação especializada para confirmação da alergia e discussão de opções terapêuticas seguras.

O medicamento Cloridrato de ondansetrona, cujo princípio ativo é o próprio cloridrato de ondansetrona, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (reação alérgica), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois não há sinais clínicos de gravidade ou desfecho fatal, e o caso permanece não resolvido ou em andamento. A reação relatada sugere um quadro alérgico, sendo importante acompanhamento médico para monitoramento e eventual ajuste terapêutico.

O medicamento Digeplus, composto por dimeticona, cloridrato de metoclopramida e pepsina, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (reação alérgica), enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa, já que o caso não evoluiu para desfecho grave e permanece em andamento. Recomenda-se acompanhamento clínico para avaliação da evolução do quadro e orientação quanto à continuidade ou suspensão do uso.

O medicamento Oxalato de escitalopram, com princípio ativo de mesmo nome, apresentou relato de hipersensibilidade (reação alérgica), classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade importante, pois o evento não foi resolvido, mas também não houve agravamento ou desfecho grave. O acompanhamento médico é fundamental para monitorar a evolução e definir conduta adequada.

O medicamento Calde mdk, contendo citrato de cálcio, colecalciferol, magnésio e menaquinona, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (reação alérgica), categorizado como distúrbio do sistema imunitário. Não há indícios

de gravidade elevada, já que o evento permanece em andamento e não houve complicações graves relatadas. É importante manter o acompanhamento clínico para avaliar a necessidade de ajustes no tratamento.

O medicamento Omega, cujo princípio ativo é omeprazol sódico, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (reação alérgica), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade relevante, pois o caso segue em andamento sem resolução, mas sem agravamento importante. Recomenda-se acompanhamento médico para monitoramento do quadro e definição de conduta.

O medicamento Sinvastatina, cujo princípio ativo é a sinvastatina, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (reação alérgica) classificado como distúrbio do sistema imunitário, com manifestação clínica descrita como metástases no fígado, embora este termo não seja típico de reações alérgicas e possa indicar confusão na descrição do evento. Não há evidência de gravidade aumentada, pois o caso não foi considerado grave e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento. A conduta deve ser a investigação clínica detalhada para esclarecer a relação causal e acompanhamento médico contínuo.

O medicamento Atenolol, com princípio ativo atenolol, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (reação alérgica) classificado como distúrbio do sistema imunitário, sendo a manifestação clínica descrita como metástases no fígado, termo que não corresponde a reações alérgicas típicas e pode indicar erro de classificação. Não há indicação de gravidade aumentada, já que o evento não foi considerado grave e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento. Recomenda-se avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e monitoramento do quadro.

O medicamento Rosuvastatina, cujo princípio ativo é rosuvastatina cálcica, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (reação alérgica) classificado como distúrbio do sistema imunitário, com manifestação clínica descrita como metástases no fígado, termo que não é característico de reações alérgicas e pode indicar erro na descrição do evento. O caso não foi considerado grave e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento, sendo necessária investigação clínica para esclarecimento e acompanhamento médico.

O medicamento Losartan, com princípio ativo losartana potássica, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (reação alérgica) classificado como distúrbio do sistema imunitário, com manifestação clínica descrita como metástases no fígado, termo que não é típico de reações alérgicas e pode indicar erro de classificação. Não há evidência de gravidade aumentada, pois o evento não foi considerado grave e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento. Recomenda-se avaliação médica detalhada para esclarecimento diagnóstico e acompanhamento do caso.

O medicamento Glifage, cujo princípio ativo é metformina, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (reação alérgica) classificado como distúrbio do sistema imunitário, com manifestação clínica descrita como metástases no fígado, termo que não é característico de reações alérgicas e pode indicar erro na descrição do evento. O caso não foi considerado grave e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento, sendo necessária investigação clínica e acompanhamento médico para esclarecimento.

O medicamento Nebacetin, que contém os princípios ativos Bacitracina e Sulfato de neomicina, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Embora a reação relatada tenha sido 'metástases no fígado', a descrição clínica indica um evento alérgico, sem evidências de gravidade aumentada ou risco imediato à vida, já que não há menção de sintomas graves ou desfecho fatal. O caso permanece em andamento, sem resolução até o momento, e recomenda-se acompanhamento clínico para monitoramento da evolução da reação.

O medicamento Vectibix, cujo princípio ativo é o Panitumumabe, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), também classificado como distúrbio do sistema imunitário. Apesar de a reação relatada envolver 'metástases no fígado', a categorização clínica aponta para um quadro alérgico, sem sinais de gravidade elevada ou risco imediato, e o desfecho permanece não resolvido. É importante manter o acompanhamento

médico para avaliar a evolução do quadro.

A Vancomicina, com princípio ativo Vancomycin, foi associada a uma reação de hipersensibilidade (alergia), enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado não grave, pois não há relato de complicações sérias ou risco à vida, e o paciente evoluiu para recuperação completa após a reação, indicando resolução do quadro alérgico.

O medicamento Vancomicina, com princípio ativo Cloridrato de vancomicina, esteve relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade aumentada ou desfecho, mas a ausência de relato de complicações graves sugere um quadro não crítico, sendo importante o acompanhamento clínico para monitorar possíveis evoluções.

O Ácido acetilsalicílico (nome comercial não informado) foi associado a uma reação de hipersensibilidade (alergia), categorizada como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, pois não há menção de sintomas severos ou risco à vida, e o paciente apresentou recuperação completa após a reação, indicando resolução do quadro alérgico.

O medicamento Dipirona monoidratada, cujo princípio ativo é a dipirona, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como reação do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações graves neste caso, e o evento foi classificado como não grave. A conduta recomendada é a suspensão do medicamento e acompanhamento clínico, conforme diretrizes para reações alérgicas leves, com orientação para evitar nova exposição e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e plano de controle.

O Paracetamol, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), que envolve uma resposta do sistema imunológico ao medicamento. O caso não apresenta sinais de gravidade ou complicações, e o desfecho foi de recuperação completa. A recomendação é evitar o uso futuro do paracetamol e consultar um especialista para avaliação e confirmação da alergia, seguindo as orientações para reações leves, sem necessidade de intervenções emergenciais.

O medicamento Metoclopramide-akr, cujo princípio ativo é metoclopramida, foi associado a uma alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), mas o medicamento não chegou a ser administrado, o que sugere que a reação foi evitada por reconhecimento prévio da alergia. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente. A conduta adequada é manter a restrição ao uso do metoclopramida e garantir que essa informação esteja registrada para evitar futuras exposições, conforme recomendações para prevenção de reações alérgicas.

O Ultravist, cujo princípio ativo é iopromida, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação do sistema imunológico. O evento foi considerado não grave e o paciente se recuperou completamente. A orientação é evitar novas exposições ao Ultravist e informar profissionais de saúde sobre a alergia, seguindo as recomendações para reações alérgicas leves, com acompanhamento médico para avaliação e confirmação diagnóstica.

O medicamento Aciclovir, com princípio ativo aciclovir sódico, foi associado a uma alergia documentada após administração, caracterizada como hipersensibilidade a produto administrado. O caso não foi considerado grave e o paciente está em processo de recuperação. A conduta recomendada é suspender o uso do aciclovir, monitorar a evolução clínica e buscar avaliação especializada para confirmação da alergia e orientação sobre alternativas terapêuticas, conforme diretrizes para reações leves.

O medicamento Dipirona Sódica, cujo princípio ativo é a dipirona, foi associado a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa (alergia medicamentosa), caracterizado por uma reação do sistema imunológico a medicamentos. Não há descrição de sintomas específicos ou gravidade aumentada neste caso, e o paciente se recuperou

totalmente após a suspensão do medicamento, o que indica uma evolução favorável e sem complicações graves.

O medicamento Prohance, que contém o princípio ativo gadoteridol, foi relacionado a uma reação alérgica ao contraste intravenoso, também chamada de alergia a contraste. Não há detalhes sobre sintomas ou gravidade, mas o paciente se recuperou completamente após o evento, sugerindo que a reação foi controlada e não houve consequências graves.

O medicamento Prohance, com gadoteridol como princípio ativo, esteve envolvido em um episódio de alergia a contraste intravenoso. Não foram fornecidos detalhes sobre sintomas ou gravidade, porém o paciente apresentou recuperação total, indicando que a reação foi resolvida sem complicações.

O medicamento Henetix, cujo princípio ativo é o iobitridol, foi associado a um episódio de hipertensão relacionado ao uso de contraste, classificado como reação alérgica a contraste. Não há descrição de sintomas adicionais ou gravidade aumentada, e o paciente se recuperou totalmente, sugerindo que a reação foi leve e controlada sem consequências graves.

O medicamento Meronem, com princípio ativo meropeném tri-hidratado, foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), mas não há detalhes sobre sintomas, gravidade ou evolução clínica. A ausência dessas informações impede uma avaliação mais precisa da gravidade ou da conduta adotada neste caso.

O medicamento Sulfato de morfina, cujo princípio ativo é o próprio sulfato de morfina, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do sistema imunológico. Não há detalhes sobre a gravidade ou desfecho do caso, mas, segundo as diretrizes clínicas, quadros alérgicos a medicamentos exigem atenção para sintomas respiratórios, cutâneos ou sistêmicos, sendo fundamental a avaliação médica para confirmação e orientação sobre futuras exposições.

O medicamento Iomeron, que tem como princípio ativo o iomeprol, foi relacionado a um episódio de alergia a meios de contraste iodados, também chamada de alergia a contraste. O caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente, o que sugere uma reação leve, compatível com manifestações alérgicas transitórias. Em situações como essa, é importante informar o histórico ao médico antes de novos exames com contraste, para prevenir recorrências e orientar condutas seguras.

O medicamento Omnipaque, cujo princípio ativo é o ioexol, foi associado a uma reação de alergia após uso intravenoso do contraste. Não há informações sobre gravidade ou evolução, mas reações alérgicas a contrastes podem variar de leves a graves, sendo essencial relatar o evento ao médico para avaliação do risco em futuras exposições e adoção de medidas preventivas.

O medicamento Ferinject, com princípio ativo carboximaltose férrica, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como não grave e com recuperação completa do paciente. Isso indica uma reação leve, que foi resolvida sem complicações, mas reforça a necessidade de acompanhamento médico para evitar novas exposições e garantir segurança em futuras administrações.

O medicamento Morphine, cujo princípio ativo é o sulfato de morfina, foi associado a um quadro de anemia relacionado à hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica que pode afetar a produção ou destruição das células do sangue. O caso não foi considerado grave, mas permanece em andamento sem resolução até o momento, o que exige acompanhamento médico para monitorar a evolução e ajustar o tratamento conforme necessário.

O medicamento Codeína, cujo princípio ativo é o fosfato de codeína, foi associado ao desenvolvimento de anemia, um quadro em que há diminuição dos glóbulos vermelhos no sangue. Essa reação foi classificada como hipersensibilidade medicamentosa, relacionada a distúrbios do sistema imunitário, mas não foi considerada grave segundo o registro clínico. O desfecho informado indica que o quadro ainda está em andamento, sem resolução.

até o momento.

O Paracetamol, com princípio ativo de mesmo nome, apresentou caso de anemia atribuída à hipersensibilidade ao medicamento, o que significa que o sistema imunológico pode ter reagido de forma inadequada ao uso. A reação foi categorizada como não grave e, até o momento, o paciente não se recuperou, permanecendo com o quadro em andamento.

O medicamento Vectibix, cujo princípio ativo é o panitumumabe, foi relacionado ao surgimento de anemia, possivelmente por hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação do sistema imunológico ao fármaco. Não há indicação de gravidade elevada no registro, e o desfecho mostra que o quadro permanece sem resolução.

A Iopromida, utilizada como contraste em exames, foi associada a um episódio de alergia ao contraste, caracterizando uma reação imunológica adversa. Não há detalhes sobre gravidade, desfecho ou evolução clínica, limitando a análise da conduta e do impacto do evento.

O medicamento Patanol s, cujo princípio ativo é o cloridrato de olopatadina, foi relacionado ao desenvolvimento de glaucoma, uma condição que pode aumentar a pressão intraocular e comprometer a visão. O evento foi classificado como suspeito de estar associado ao uso do medicamento, não foi considerado grave e o desfecho permanece desconhecido.

O medicamento Betoptic S, que contém o princípio ativo cloridrato de betaxolol, foi associado a um quadro de alergia ocular, manifestando-se como inflamação ou outros sintomas nos olhos (distúrbios oculares). Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e não foram relatados sinais de complicação grave, sugerindo que a reação foi leve e localizada.

O medicamento Meclin, cujo princípio ativo é o cloridrato de meclozina, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (reação alérgica), sem sinais de gravidade importante e com resolução completa do quadro. A reação foi considerada leve, sem complicações, e o paciente se recuperou totalmente.

O medicamento Alenia, composto por budesonida micronizada e fumarato de formoterol, esteve associado a um episódio de hipersensibilidade (reação alérgica), sem sinais de gravidade ou complicações, e o paciente apresentou recuperação completa. O evento foi leve e não houve necessidade de intervenções adicionais.

A pregabalina, princípio ativo do medicamento Pregabalina, foi relacionada a um quadro de hipersensibilidade (reação alérgica), sem gravidade significativa e com resolução total dos sintomas, indicando um evento leve e autolimitado.

O medicamento Letrozol, cujo princípio ativo é letrozole, foi associado a uma reação de hipersensibilidade (alergia), sem sinais de gravidade e com recuperação completa do paciente, caracterizando um evento leve e sem complicações.

O medicamento Verzenios, cujo princípio ativo é o abemaciclib, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Embora a reação tenha sido descrita como 'Dengue', o termo técnico utilizado foi hipersensibilidade, sugerindo um quadro alérgico inespecífico. Não há indicação de gravidade aumentada ou complicações, e o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente. A conduta recomendada nesses casos é a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento clínico para evitar novas exposições.

O medicamento Restiva, que contém buprenorfina como princípio ativo, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como um distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, pois permanece em andamento sem resolução até o momento. Diante de reações alérgicas graves, é fundamental interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica imediata para manejo



adequado e prevenção de complicações.

O Dotarem, cujo princípio ativo é o gadobenato de dimeglumina, foi associado a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma alergia ao medicamento, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade aumentada, e o paciente evoluiu para recuperação completa após o evento. Nesses casos, recomenda-se evitar novas exposições ao agente suspeito e informar a equipe médica sobre o histórico de alergia.

O medicamento Henetix, com princípio ativo iobitridol, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, caracterizado como uma reação alérgica ao medicamento e classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não houve gravidade aumentada e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta adequada inclui evitar o uso futuro do agente suspeito e comunicar o histórico de alergia ao profissional de saúde.

O Dotarem, contendo gadobenato de dimeglumina, foi novamente associado a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma alergia ao medicamento, classificada como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa. Recomenda-se evitar novas exposições ao medicamento e informar o histórico de alergia ao médico responsável.

O medicamento Hidrocortisona, cujo princípio ativo é o succinato sódico de hidrocortisona, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (reação alérgica), classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois não há evidências clínicas de complicações graves ou risco imediato à vida, e o desfecho relatado é de não recuperação ou evolução em andamento. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico, observando sinais de agravamento, e buscar avaliação especializada caso haja piora dos sintomas.

O medicamento Zoladex, com princípio ativo acetato de goserrelina, apresentou relato de hipersensibilidade (reação alérgica), enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade importante, já que não foram descritas complicações graves e o quadro permanece não resolvido ou em andamento. Recomenda-se acompanhamento médico para monitoramento da evolução e orientação quanto à necessidade de intervenção caso haja piora clínica.

O medicamento Concor, cujo princípio ativo é bisoprolol hemifumarato, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (reação alérgica), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa, pois não foram relatadas complicações graves e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento. A orientação é manter acompanhamento clínico e buscar avaliação médica se houver agravamento dos sintomas.

O medicamento Própolis, com princípio ativo também denominado própolis, foi associado a uma reação de hipersensibilidade (alergia), categorizada como distúrbio do sistema imunitário. Não há indícios de gravidade relevante, já que não foram relatadas complicações graves e o quadro segue não resolvido ou em andamento. Recomenda-se observação clínica e avaliação médica caso haja piora dos sintomas.

O medicamento Zometa, cujo princípio ativo é ácido zoledrônico monoidratado, foi relacionado a um caso de hipersensibilidade (reação alérgica), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade importante, pois não foram descritas complicações graves e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento. A conduta sugerida é acompanhamento clínico e busca de avaliação médica se houver agravamento do quadro.

O medicamento Acetato de abiraterona, cujo princípio ativo é o próprio acetato de abiraterona, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (reação alérgica), classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois não há relato de gravidade clínica importante e o desfecho informado é de não recuperação ou evolução ainda em andamento. A conduta deve ser baseada em avaliação clínica estruturada

para confirmação da relação causal e acompanhamento do quadro, conforme orientações da ASBAI para reações alérgicas leves.

O medicamento Benicar, cujo princípio ativo é a olmesartana medoxomila, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (reação alérgica), enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa, já que não foi relatada gravidade clínica e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento. Recomenda-se acompanhamento clínico e avaliação especializada para confirmação diagnóstica e definição da melhor conduta, conforme diretrizes para quadros alérgicos leves.

O medicamento Esomeprazol, com princípio ativo esomeprazole, apresentou associação com hipersensibilidade (reação alérgica), sendo classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade importante, pois não foi relatada gravidade clínica e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento. A orientação é realizar avaliação clínica detalhada e acompanhamento, conforme recomendado para reações alérgicas leves.

O medicamento Levotiroxina, cujo princípio ativo é levothyroxine, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (reação alérgica), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade relevante, pois não há relato de gravidade clínica e o desfecho informado é de não recuperação ou evolução ainda em andamento. Recomenda-se avaliação clínica estruturada e acompanhamento do caso, conforme diretrizes para quadros alérgicos leves.

O medicamento Prednisona, com princípio ativo prednisone, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (reação alérgica), enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa, já que não foi relatada gravidade clínica e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento. A conduta recomendada é acompanhamento clínico e avaliação especializada para confirmação diagnóstica, conforme orientações para reações alérgicas leves.

O medicamento Venaflon, que contém os princípios ativos diosmina e hesperidina, foi associado a um quadro de alergia ao leite, classificado como uma reação do sistema imunológico relacionada a alergias a alimentos, aditivos alimentares, medicamentos e outras substâncias químicas. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações graves, e o desfecho informado é de não recuperação ou evolução ainda em andamento. A relação entre o medicamento e a reação é considerada suspeita, sendo importante acompanhamento clínico para monitorar a evolução do quadro.

O medicamento Vit D, cujo princípio ativo é vitamina D, foi relacionado a um episódio de alergia ao leite, caracterizado como uma reação imunológica envolvendo alergias a alimentos, aditivos e medicamentos. Não há evidências de gravidade significativa ou complicações graves, e o caso permanece sem resolução até o momento. A suspeita de relação entre o uso do medicamento e a reação exige observação clínica contínua para avaliar possíveis desdobramentos.

O medicamento Glifage, que tem como princípio ativo a metformina, foi associado a uma reação de alergia ao leite, enquadrada como uma manifestação do sistema imunológico relacionada a alergias alimentares e medicamentosas. Não há sinais de gravidade importante ou evolução para quadros graves, e o desfecho permanece não resolvido. A relação entre o uso do medicamento e a reação é considerada suspeita, sendo recomendada a continuidade do acompanhamento médico.

O medicamento Lamotrigina, cujo princípio ativo é lamotrigina, foi relacionado a um episódio de alergia ao leite, classificado como uma reação imunológica envolvendo alergias a alimentos, aditivos e medicamentos. Não há indícios de gravidade elevada ou complicações sérias, e o quadro segue sem resolução até o momento. A suspeita de relação entre o medicamento e a reação justifica o monitoramento clínico para avaliar a evolução.

O medicamento Omeprazol, com princípio ativo omeprazol, foi associado a uma reação de alergia ao leite, caracterizada como uma resposta do sistema imunológico a alimentos, aditivos ou medicamentos. Não há

evidências de gravidade importante ou evolução para quadros graves, e o desfecho informado é de não recuperação ou caso ainda em andamento. A relação entre o uso do medicamento e a reação é considerada suspeita, sendo necessário acompanhamento clínico para monitorar o progresso do quadro.

O medicamento Alopurinol, cujo princípio ativo é o próprio alopurinol, foi associado a uma reação descrita como alergia ao leite, classificada entre as alergias a alimentos, aditivos alimentares, medicamentos e outras substâncias químicas, afetando o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações graves, pois o caso não foi considerado grave e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento. A relação entre o medicamento e a reação é suspeita, e não há informações sobre condutas adotadas, sendo importante acompanhamento clínico para monitorar a evolução do quadro.

O medicamento Somalgin cardio, que contém ácido acetilsalicílico, glicinato de alumínio e carbonato de magnésio como princípios ativos, foi relacionado a uma reação de alergia ao leite, enquadrada entre alergias a alimentos, aditivos alimentares, medicamentos e outras substâncias químicas, com envolvimento do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade importante, já que o caso não foi considerado grave e o desfecho segue não resolvido ou em andamento. A suspeita de relação com o medicamento exige observação clínica e avaliação médica para acompanhamento da evolução.

O medicamento Cloridrato de sotalol, com o mesmo princípio ativo, foi associado a uma reação de alergia ao leite, classificada como alergia a alimentos, aditivos alimentares, medicamentos e outras substâncias químicas, afetando o sistema imunológico. Não há evidências de gravidade significativa, pois o caso não foi considerado grave e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento. A relação com o medicamento é suspeita, sendo recomendada a continuidade do acompanhamento clínico para avaliar possíveis desdobramentos.

O medicamento Sinvastatina, cujo princípio ativo é a sinvastatina, foi relacionado a uma reação de alergia ao leite, enquadrada entre alergias a alimentos, aditivos alimentares, medicamentos e outras substâncias químicas, com envolvimento do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade relevante, já que o caso não foi considerado grave e o desfecho segue não resolvido ou em andamento. A suspeita de relação com o medicamento sugere a necessidade de acompanhamento clínico para monitoramento da evolução.

O medicamento Ezetimiba, com princípio ativo ezetimibe, foi associado a uma reação de alergia ao leite, classificada como alergia a alimentos, aditivos alimentares, medicamentos e outras substâncias químicas, afetando o sistema imunológico. Não há sinais de gravidade importante, pois o caso não foi considerado grave e o desfecho permanece não resolvido ou em andamento. A relação suspeita com o medicamento indica a importância de acompanhamento clínico para avaliar a evolução do quadro.

O medicamento Glyxambi, que contém os princípios ativos empagliflozina e linagliptina, foi associado a um quadro de alergia ao leite, classificado como uma reação de hipersensibilidade alimentar (alergia a alimentos) dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois não há relato de desfecho grave ou complicações importantes, e o caso permanece em andamento sem resolução até o momento. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico, evitar exposição ao alérgeno suspeito e buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação sobre controle ambiental e alimentar.

O medicamento Venaflon, composto por diosmina e hesperidina, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, caracterizado como um quadro clínico alérgico dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa, pois não foi relatado desfecho grave ou complicações, e o desfecho permanece desconhecido. Recomenda-se observação clínica, evitar reexposição ao medicamento suspeito e procurar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição do melhor manejo.

O medicamento Vit D, cujo princípio ativo é vitamina D, foi associado a uma reação de hipersensibilidade, enquadrada como um quadro clínico alérgico dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade relevante, já que não há relato de desfecho grave ou complicações, e o desfecho permanece

desconhecido. A orientação é evitar o uso do medicamento até avaliação médica, que poderá confirmar o diagnóstico e orientar sobre alternativas seguras.

O medicamento Glifage, que contém metformina, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, considerado um quadro clínico alérgico dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indícios de gravidade importante, pois não há relato de desfecho grave ou complicações, e o desfecho permanece desconhecido. Recomenda-se evitar o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição do tratamento mais adequado.

O medicamento Lamotrigina, cujo princípio ativo é lamotrigina, foi associado a uma reação de hipersensibilidade, classificada como um quadro clínico alérgico dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa, pois não foi relatado desfecho grave ou complicações, e o desfecho permanece desconhecido. A conduta recomendada é suspender o uso do medicamento até avaliação médica, que poderá confirmar o diagnóstico e orientar sobre alternativas terapêuticas seguras.

O medicamento Omeprazol, cujo princípio ativo é o omeprazole, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (reação alérgica) classificado como um distúrbio do sistema imunitário, sem indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido. Não há informações sobre ação adotada ou evolução do caso, e a suspeita de relação com o medicamento foi registrada, mas sem evidências de complicações graves, sugerindo um quadro leve de alergia medicamentosa.

O medicamento Alopurinol, com princípio ativo alopurinol, apresentou relato de hipersensibilidade (reação alérgica) enquadrada como distúrbio do sistema imunitário, sem sinais de gravidade importante ou desfecho informado. Não há detalhes sobre conduta ou evolução, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, indicando um possível quadro leve de alergia sem complicações graves.

O medicamento Somalgin cardio, composto por ácido acetilsalicílico, glicinato de alumínio e carbonato de magnésio, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (reação alérgica) classificado como distúrbio do sistema imunitário, sem evidências de gravidade significativa ou desfecho relatado. A suspeita de relação com o medicamento foi registrada, mas não há informações sobre a evolução clínica, sugerindo um quadro leve de alergia medicamentosa.

O medicamento Cloridrato de sotalol, cujo princípio ativo é o próprio cloridrato de sotalol, foi associado a um caso de hipersensibilidade (reação alérgica) enquadrado como distúrbio do sistema imunitário, sem indicação de gravidade relevante ou desfecho conhecido. Não há dados sobre a conduta adotada ou evolução, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sugerindo um quadro leve de alergia sem complicações.

O medicamento Sinvastatina, com princípio ativo sinvastatina, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (reação alérgica) classificado como distúrbio do sistema imunitário, sem sinais de gravidade importante ou desfecho informado. Não há informações sobre a conduta adotada ou evolução clínica, e a suspeita de relação com o medicamento foi registrada, indicando um quadro leve de alergia medicamentosa.

O medicamento Ezetimiba (princípio ativo: Ezetimibe) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, que é uma reação alérgica do sistema imunológico, descrita de forma geral como um quadro clínico alérgico. Não há indicação de gravidade importante ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Recomenda-se atenção clínica para sintomas alérgicos, com avaliação médica caso haja sinais persistentes ou agravamento.

O medicamento Glyxambi, que contém os princípios ativos Empagliflozina e Linagliptina, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, caracterizado como uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há detalhes sobre gravidade ou evolução do caso, e a relação com o medicamento é suspeita. É importante monitorar sintomas alérgicos e buscar avaliação médica se houver piora ou persistência dos sintomas.

A Dipirona sódica (princípio ativo: Dipirona) foi associada a uma alergia documentada após administração, caracterizada como hipersensibilidade ao produto. O evento foi classificado como um problema relacionado ao uso do medicamento, mas não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente. A conduta adequada inclui evitar nova exposição ao medicamento e informar profissionais de saúde sobre a alergia confirmada.

O medicamento Jardiance (princípio ativo: Empagliflozina) foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como clinicamente significativo e considerado grave, com evolução ainda em andamento e sem resolução até o momento. Diante da gravidade, é fundamental acompanhamento médico rigoroso e possível suspensão do medicamento, conforme avaliação clínica.

O medicamento Januvia (princípio ativo: Fosfato de sitagliptina) foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), considerado clinicamente significativo e grave, sem resolução até o momento. Diante da gravidade do quadro, recomenda-se acompanhamento médico imediato e reavaliação do uso do medicamento para evitar complicações maiores.

O medicamento Erbitux, cujo princípio ativo é o cetuximabe, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como clinicamente significativo e grave, com evolução ainda não resolvida. A reação envolve manifestações do sistema imunológico e, segundo o registro, permanece em andamento, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico rigoroso e possível intervenção especializada para controle da reação alérgica.

O medicamento Quetia, contendo hemifumarato de quetiapina, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), mas sem indicação de gravidade relevante e com desfecho desconhecido. Não há detalhes sobre a evolução clínica ou conduta adotada, sendo importante monitorar sintomas e buscar avaliação médica caso haja persistência ou agravamento.

O medicamento Rosuvastatin, cujo princípio ativo é a rosuvastatina, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), sem evidências de gravidade significativa e com desfecho não informado. A ausência de informações sobre a evolução clínica sugere a necessidade de observação e orientação médica caso surjam sintomas persistentes.

O medicamento Vicog, que contém vimpocetina, foi relacionado a uma reação de hipersensibilidade (alergia), sem gravidade aparente e com desfecho desconhecido. Não há detalhes sobre a evolução ou conduta, sendo recomendada atenção a possíveis sintomas e busca de avaliação médica se necessário.

O medicamento Valsartan, cujo princípio ativo é a valsartana, foi associado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), sem indicação de gravidade e com desfecho não informado. Diante da ausência de informações sobre a evolução, é importante monitorar sintomas e procurar orientação médica caso haja piora ou persistência do quadro.

O medicamento Plasil, cujo princípio ativo é o cloridrato de metoclopramida, foi associado a um quadro de depressão descrito como reação de hipersensibilidade, classificado dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A ausência de sinais de gravidade sugere que a reação foi leve, mas é importante monitorar sintomas e buscar avaliação médica para confirmação e orientação adequada.

O medicamento Digesan, que contém kainic acid e santonin como princípios ativos, foi relacionado a um episódio de depressão interpretado como hipersensibilidade, enquadrado nos distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade significativa ou desfecho, e a relação com o medicamento é suspeita. Diante da ausência de sinais de gravidade, a reação pode ser considerada leve, sendo recomendada a observação clínica e avaliação médica para esclarecimento do quadro.

O medicamento Frontal, cujo princípio ativo é o alprazolam, foi associado a um quadro de depressão descrito como reação de hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade importante nem desfecho relatado, e a relação com o medicamento é suspeita. Considerando a ausência de sinais de gravidade, trata-se provavelmente de uma reação leve, sendo indicada a avaliação médica para confirmação e conduta adequada.

O medicamento Frontal, com princípio ativo alprazolam, foi novamente relacionado a um episódio de depressão interpretado como hipersensibilidade, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há registro de gravidade relevante ou desfecho, e a relação com o medicamento permanece suspeita. Na ausência de sinais de gravidade, a reação é considerada leve, recomendando-se acompanhamento clínico para esclarecimento e manejo.

O medicamento Ibuprofeno, cujo princípio ativo é ibuprofeno, foi associado a um caso de surdez descrito como reação de hipersensibilidade, classificada entre os distúrbios do sistema imunitário. O desfecho informado é de não recuperação ou quadro em andamento, mas não há evidência de gravidade elevada. A relação com o medicamento é suspeita, e diante da persistência dos sintomas, é fundamental buscar avaliação médica para investigação e definição da conduta.

O medicamento Fosfato sodico de prednisolona, cujo princípio ativo é o fosfato sódico de prednisolona, foi associado ao evento de surdez em um caso de hipersensibilidade (alergia), classificado como um quadro clínico alérgico relacionado ao sistema imunológico. Não há informações sobre nome comercial. A gravidade não foi especificada e não há indicação de que o caso seja considerado grave, segundo o registro clínico. O desfecho relatado é de não recuperação ou resolução até o momento, indicando que o quadro permanece em andamento. A relação entre o medicamento e a reação foi considerada suspeita, e não há detalhes sobre condutas adotadas.

O medicamento Loratadina, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado ao surgimento de surdez em um contexto de hipersensibilidade (alergia), sendo classificado como um quadro clínico alérgico do sistema imunológico. Não há menção a nome comercial. O registro não indica gravidade elevada e o caso não foi considerado grave. O desfecho permanece não resolvido, com o paciente ainda apresentando sintomas. A relação entre o uso do medicamento e a reação adversa é considerada suspeita, sem informações adicionais sobre a conduta adotada.

O medicamento Cloridrato de fexofenadina, cujo princípio ativo é o próprio cloridrato de fexofenadina, foi associado ao evento de surdez em um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como um quadro clínico alérgico do sistema imunológico. Não há nome comercial informado. O caso não foi considerado grave e a gravidade não foi detalhada. O desfecho indica que o paciente não se recuperou até o momento, com a reação ainda em andamento. A relação entre o medicamento e a reação é suspeita, sem detalhes sobre medidas tomadas.

O medicamento Histamin, cujo princípio ativo é o maleato de dexclorfeniramina, foi relacionado ao desenvolvimento de surdez em um contexto de hipersensibilidade (alergia), sendo classificado como um quadro clínico alérgico do sistema imunológico. O nome comercial Histamin está presente, mas não há informações adicionais sobre gravidade, que não foi considerada elevada. O desfecho permanece não resolvido, com sintomas em andamento, e a relação entre o medicamento e a reação é considerada suspeita, sem detalhes sobre a conduta adotada.

O medicamento Cloridrato de fingolimode, com princípio ativo de mesmo nome e sem nome comercial informado, foi associado ao evento de surdez em um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como um quadro clínico alérgico do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada e o caso não foi considerado grave. O desfecho permanece não resolvido, com sintomas em andamento, e a relação entre o medicamento e a reação é considerada suspeita, sem informações sobre medidas tomadas.

O medicamento Lyrica, cujo princípio ativo é o pregabalina, foi associado a um quadro de arritmia em um contexto de hipersensibilidade medicamentosa, classificada como uma reação alérgica a medicamentos. Não há indicação

de gravidade elevada ou complicações graves, pois não há relato de desfecho crítico ou necessidade de intervenção urgente, mas o caso permanece não resolvido até o momento. Recomenda-se acompanhamento clínico para monitorar a evolução da reação e avaliar a necessidade de ajuste terapêutico, conforme orientação médica.

Gabapentina, com princípio ativo gabapentin, foi relacionada a um episódio de alergia caracterizado como hipersensibilidade, enquadrando-se em quadros clínicos alérgicos. O evento não foi considerado grave e o paciente já se encontra recuperado, indicando resolução espontânea ou após medidas simples. A conduta recomendada é evitar nova exposição ao medicamento e manter acompanhamento para prevenção de recorrências.

O produto Aptamil, cujo princípio ativo é descrito como 'poder do leite', foi associado ao aparecimento de sangue nas fezes, sugerindo uma possível alergia ao leite. Trata-se de uma reação alérgica alimentar, sem sinais de gravidade aumentada ou complicações relatadas, e o desfecho permanece desconhecido. Recomenda-se avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre substituição alimentar adequada.

Nactali, contendo desogestrel como princípio ativo, foi relacionado ao sintoma de sangue nas fezes, sendo classificado como possível alergia ao leite. Não há evidências de gravidade aumentada ou complicações graves, e o desfecho do caso é desconhecido. É importante buscar avaliação médica para investigar a relação causal e definir conduta apropriada, especialmente se houver persistência dos sintomas.

O medicamento Rosuvastatin, com princípio ativo de mesmo nome, foi associado a um evento descrito como cirurgia em contexto de hipersensibilidade, classificado como quadro clínico alérgico. Não há detalhes sobre a gravidade da reação ou sobre o motivo da cirurgia, e o desfecho permanece desconhecido. Recomenda-se acompanhamento médico para esclarecer a relação entre o uso do medicamento e o evento cirúrgico, além de monitorar possíveis manifestações alérgicas.

O medicamento Pioglitazone, cujo princípio ativo também é pioglitazona, está relacionado a um caso de hipersensibilidade (reação alérgica), classificada como um quadro clínico alérgico dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre nome comercial, gravidade clínica ou desfecho, mas a ausência de indicação de gravidade sugere que não houve manifestação grave. A relação do medicamento com a reação é considerada suspeita, e não há detalhes sobre a conduta adotada ou evolução do caso.

O medicamento Prednisona, com princípio ativo prednisona, foi associado a um episódio de hipersensibilidade (reação alérgica), enquadrado como quadro clínico alérgico nos distúrbios do sistema imunitário. Não há informação sobre nome comercial, gravidade clínica ou desfecho, e não foi relatada gravidade importante, sugerindo ausência de complicações graves. A relação do medicamento com a reação é suspeita, sem detalhes adicionais sobre a conduta ou evolução clínica.

O medicamento Atenolol, cujo princípio ativo também é atenolol, está relacionado a um caso de hipersensibilidade (reação alérgica), classificado como quadro clínico alérgico dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há informação sobre nome comercial, gravidade clínica ou desfecho, e não foi relatada gravidade, indicando que não houve manifestação grave. A relação do medicamento com a reação é considerada suspeita, sem detalhes sobre a conduta adotada ou evolução do caso.

O medicamento Hydrochlorothiazide, com princípio ativo hidroclorotiazida, foi associado a um episódio de hipersensibilidade (reação alérgica), categorizado como quadro clínico alérgico nos distúrbios do sistema imunitário. Não há informação sobre nome comercial, gravidade clínica ou desfecho, e não foi relatada gravidade, sugerindo ausência de complicações graves. A relação do medicamento com a reação é suspeita, sem detalhes adicionais sobre a conduta ou evolução clínica.

O medicamento Chlortalidone, cujo princípio ativo também é clortalidona, está relacionado a um caso de hipersensibilidade (reação alérgica), classificado como quadro clínico alérgico dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há informação sobre nome comercial, gravidade clínica ou desfecho, e não foi relatada gravidade, indicando que não houve manifestação grave. A relação do medicamento com a reação é considerada suspeita, sem detalhes sobre a conduta adotada ou evolução do caso.

O medicamento Losartan potassium (princípio ativo: Losartana potássica) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, que corresponde a uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade clínica, mas o registro indica que não foi considerada uma reação grave e o desfecho permanece desconhecido. A relação com o medicamento é suspeita, e, na ausência de informações adicionais, recomenda-se acompanhamento clínico para monitorar possíveis recorrências ou agravamento.

O medicamento Benlysta (princípio ativo: Belimumabe) foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há descrição de sintomas detalhados ou indicação de gravidade significativa, sendo classificada como não grave e com desfecho desconhecido. A suspeita de relação com o medicamento sugere a necessidade de vigilância clínica, especialmente em caso de novas exposições.

O medicamento Ultravist (princípio ativo: Iopromide) foi associado a uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma alergia, envolvendo o sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente após o episódio. A relação com o medicamento é suspeita, e a conduta adequada inclui evitar novas exposições ao agente e informar profissionais de saúde sobre o histórico de alergia a contraste.

O medicamento Ultravist (princípio ativo: Iopromide) esteve envolvido em um caso de hipersensibilidade, caracterizado como uma reação alérgica do sistema imunológico. Não foi considerada uma reação grave e o paciente apresentou recuperação completa. A relação com o medicamento é suspeita, sendo importante evitar reexposição e comunicar o histórico de alergia em futuras indicações de contraste.

O medicamento Ultravist (princípio ativo: Iopromide) foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. O evento não foi classificado como grave e o paciente se recuperou totalmente. A suspeita de relação com o medicamento reforça a necessidade de evitar novas exposições e de informar profissionais de saúde sobre essa alergia.

O medicamento Simeticone, cujo princípio ativo também é simeticone, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), caracterizado como reação alérgica do tipo não especificada. A gravidade do evento foi considerada alta, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando a necessidade de atenção médica imediata. O desfecho da reação não foi informado, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita.

O medicamento Henetix, que contém o princípio ativo iobitridol, foi relacionado a uma reação de alergia a meios de contraste iodados, manifestando-se como hipersensibilidade ao contraste. O evento foi classificado como suspeito e, apesar de não haver detalhes sobre a gravidade, o paciente se recuperou totalmente após a reação.

A metoclopramida, cujo princípio ativo é metoclopramida, foi associada a um episódio de hipersensibilidade (alergia), caracterizado como reação alérgica não especificada. O evento foi considerado grave, pois envolveu ameaça à vida e necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando a importância de intervenção médica imediata. O paciente se recuperou após a reação, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita.

O medicamento Ceftriaxona, com princípio ativo ceftriaxona, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), classificado como reação alérgica não especificada. O evento não foi considerado grave, pois não houve ameaça à vida nem necessidade de hospitalização, e o paciente se recuperou totalmente após a reação. A relação



com o medicamento foi considerada suspeita.

O iodo, utilizado como medicamento, foi associado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), caracterizado como reação alérgica não especificada. O evento não foi considerado grave, pois não houve ameaça à vida nem necessidade de hospitalização, e o paciente se recuperou totalmente após a reação. A relação com o medicamento foi considerada suspeita.

O medicamento Henetix, que contém os princípios ativos lobitridol, sodium calcium edetate, trometamol e cloridrato de trometamol, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade (reação alérgica), pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade aumentada neste caso, e o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo uma reação leve e autolimitada, compatível com quadros clínicos alérgicos leves, conforme as diretrizes da ASBAI.

O medicamento Omnitrope, cujo princípio ativo é a somatropina, foi relacionado a uma reação de alergia (hipersensibilidade), também classificada como distúrbio do sistema imunitário. Neste caso, a reação foi considerada clinicamente significativa e grave, o que indica que houve impacto relevante para o paciente, mas o desfecho foi favorável, com recuperação completa após o evento. Isso reforça a importância de monitoramento e conduta médica adequada em casos de hipersensibilidade significativa.

O medicamento Ultravist, com princípio ativo iopromida, foi associado a uma alergia medicamentosa, descrita como hipersensibilidade medicamentosa, pertencente ao grupo de alergias a medicamentos e distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade aumentada, e o paciente se recuperou totalmente, sugerindo uma reação leve e autolimitada, compatível com quadros de hipersensibilidade leve segundo as recomendações clínicas.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, foi relacionado a uma alergia medicamentosa, caracterizada como hipersensibilidade medicamentosa e classificada entre as alergias a medicamentos e distúrbios do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade aumentada, e o paciente apresentou recuperação completa, indicando um quadro leve e autolimitado, conforme esperado para reações alérgicas leves.

O medicamento Mekinist, que contém dimetilsulfóxido de trametinibe como princípio ativo, foi associado a uma reação de alergia (hipersensibilidade), enquadrada entre os quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade aumentada, e o paciente se recuperou totalmente, sugerindo uma reação leve e autolimitada, compatível com quadros de hipersensibilidade leve conforme as diretrizes clínicas.

O medicamento Tafinlar, cujo princípio ativo é o mesilato de dabrafenibe, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, que se enquadra em reações alérgicas do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade clínica relevante neste caso, e o paciente apresentou recuperação completa após o evento, sugerindo uma evolução favorável e resolução do quadro sem complicações.

O medicamento Mekinist, com princípio ativo dimetilsulfóxido de trametinibe, esteve relacionado a um episódio de alergia manifestado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo de reações alérgicas do sistema imunológico. O caso foi considerado clinicamente significativo, indicando maior gravidade, embora o desfecho não tenha sido informado, o que impede avaliar a evolução do quadro.

O medicamento Tafinlar, cujo princípio ativo é o mesilato de dabrafenibe, foi relacionado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, classificada como clinicamente significativa, o que sugere maior gravidade do quadro. Não há informação sobre o desfecho, impossibilitando saber se houve resolução ou persistência dos sintomas.

A vitamina B9, cujo princípio ativo é o ácido fólico, foi associada a um quadro de artropatia psoriática, descrito como hipersensibilidade e incluído entre as reações alérgicas do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade aumentada, mas o quadro permanece em andamento, sem resolução até o momento.

O medicamento Metotrexate, com princípio ativo metotrexato de sódio, foi relacionado a um caso de artropatia psoriática, caracterizado por hipersensibilidade e pertencente ao grupo de reações alérgicas do sistema imunológico. Não há evidência de gravidade aumentada, porém o quadro segue sem resolução, estando em andamento.

O medicamento Simponi, cujo princípio ativo é o golimumabe, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), manifestado durante o tratamento de artropatia psoriática. Embora a reação tenha sido classificada como relacionada a distúrbios do sistema imunitário, não há indicação de gravidade elevada, pois não foi considerado um caso grave e o paciente permanece sem resolução completa do quadro. A conduta deve incluir acompanhamento clínico para monitorar a evolução da reação, com atenção à persistência dos sintomas.

O golimumabe, citado tanto como nome comercial quanto princípio ativo, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia) em paciente com artropatia psoriática. A reação foi enquadrada como distúrbio do sistema imunitário, mas não foi considerada grave, e o quadro permanece em andamento, sem resolução até o momento. Recomenda-se acompanhamento médico para avaliar a evolução e necessidade de ajustes terapêuticos.

O medicamento Buscopan composto, contendo butilbrometo de escopolamina e dipirona, foi associado a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa (alergia ao medicamento), classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não houve gravidade significativa, e o paciente se recuperou após a suspensão do medicamento, indicando resolução completa do quadro. A conduta adequada foi a interrupção do uso do medicamento suspeito, resultando em melhora dos sintomas.

A carboplatina, utilizada como princípio ativo, provocou uma reação de hipersensibilidade documentada após administração, caracterizada como um erro ou problema relacionado ao monitoramento do produto e classificada entre lesões e complicações de procedimentos. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou após a reação, sugerindo que a conduta adotada foi suficiente para resolução do evento adverso.

O gadobutrol, utilizado como contraste, desencadeou uma reação alérgica (alergia a contraste), enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Não houve gravidade relevante e o paciente se recuperou completamente após o evento, indicando que a conduta adotada foi eficaz para resolução da reação adversa.

O medicamento Iopromida, cujo princípio ativo é Iopromide, foi associado a um episódio de alergia a contraste, caracterizado como uma reação do sistema imunológico a substâncias químicas utilizadas em exames de imagem. Não há indicação de gravidade aumentada ou necessidade de hospitalização, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada é evitar novas exposições ao contraste e informar a equipe médica sobre o histórico de alergia em procedimentos futuros.

O uso do medicamento Butilbrometo de escopolamina associado à dipirona sódica resultou em uma reação alérgica (hipersensibilidade), envolvendo o sistema imunológico. Não há relato de gravidade significativa ou complicações, e o paciente se recuperou completamente. Recomenda-se evitar o uso futuro desses medicamentos e buscar avaliação médica para confirmação da alergia e orientação adequada.

A administração de Acebrofilina levou a uma alergia documentada ao medicamento, caracterizada como hipersensibilidade ao produto administrado. O evento não foi grave e o paciente se recuperou sem complicações. É importante registrar essa alergia no prontuário e evitar o uso futuro da acebrofilina, além de informar profissionais de saúde em atendimentos posteriores.

O medicamento Tramal 100, cujo princípio ativo é Tramadol, foi relacionado a uma alergia documentada ao medicamento administrado, configurando um quadro de hipersensibilidade. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou evolução clínica, portanto recomenda-se cautela e investigação adicional antes de nova exposição ao

tramadol.

A administração de Ceftriaxona, cujo princípio ativo é ceftriaxona dissódica hemieptaidratada, resultou em uma reação alérgica (hipersensibilidade) que exigiu hospitalização ou prolongamento da internação, indicando gravidade aumentada. O paciente se recuperou após o evento. Diante desse histórico, é fundamental evitar o uso futuro da ceftriaxona e informar a equipe médica sobre a alergia para prevenir novas reações graves.

O medicamento Clindamicina, cujo princípio ativo é o fosfato de clindamicina, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Neste caso, a reação foi considerada grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando a necessidade de atenção médica imediata. O desfecho relatado foi de recuperação completa após a conduta adequada.

A Oxacilina, com princípio ativo oxacillin, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade), também enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. A gravidade foi confirmada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando um evento adverso importante que exigiu intervenção médica. O paciente evoluiu para recuperação total após o manejo apropriado.

O medicamento Tramadol, cujo princípio ativo é o próprio tramadol, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como distúrbio do sistema imunitário. Não há informações detalhadas sobre a gravidade, evolução clínica ou desfecho, portanto não é possível afirmar a extensão do quadro ou as medidas adotadas.

A Bromoprida, com princípio ativo bromopride, esteve associada a uma reação alérgica (hipersensibilidade), classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não foram fornecidos dados sobre a gravidade do evento, conduta adotada ou desfecho, impossibilitando detalhar a evolução clínica do caso.

O Cetoprofeno, cujo princípio ativo é cetoprofeno, foi implicado em um episódio de alergia (hipersensibilidade), enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. Não há informações disponíveis sobre a gravidade da reação, conduta tomada ou desfecho, o que limita a análise da evolução do evento adverso.

O medicamento Morfin, cujo princípio ativo é o cloridrato de morfina, foi associado ao surgimento de prurido, um quadro de hipersensibilidade (alergia) caracterizado por coceira. Embora não haja informação detalhada sobre a gravidade ou desfecho neste caso, o prurido relacionado à morfina é uma manifestação alérgica do sistema imune e deve ser monitorado, especialmente se houver outros sintomas associados.

O medicamento Symbicort, que contém budesonida micronizada e fumarato de formoterol, foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como clinicamente significativo e considerado grave. O paciente apresentou reação alérgica, mas evoluiu para recuperação completa. Em situações como essa, é fundamental interromper o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição do tratamento, conforme orientações para quadros alérgicos moderados a graves.

O medicamento Tylenol, cujo princípio ativo é o paracetamol, foi associado a um acidente vascular cerebral talâmico, registrado como reação de hipersensibilidade e considerado clinicamente significativo e grave. O desfecho informado foi não recuperado, indicando que o evento ainda está em andamento. Diante de reações graves e persistentes, é essencial interromper o uso do medicamento e procurar atendimento médico imediato para investigação e manejo adequado.

O medicamento Dipyrone, com princípio ativo dipirone, foi relacionado a um acidente vascular cerebral talâmico, classificado como reação de hipersensibilidade, clinicamente significativa e grave. O evento permanece sem resolução, o que reforça a necessidade de suspensão do medicamento e avaliação médica urgente para investigação e tratamento apropriado de reações adversas graves.

O medicamento Donaren, cujo princípio ativo é o cloridrato de trazodona, foi associado a um acidente vascular cerebral talâmico, caracterizado como reação de hipersensibilidade, clinicamente significativa e grave. O caso permanece em andamento, sem recuperação até o momento, sendo fundamental interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica especializada para investigação e conduta diante de eventos adversos graves.

O medicamento Alprazolam, cujo princípio ativo é o próprio alprazolam, foi associado a um acidente vascular cerebral talâmico em um caso de hipersensibilidade, caracterizado como um quadro clínico alérgico relacionado ao sistema imunitário. Trata-se de uma reação considerada clinicamente significativa e grave, conforme evidenciado pela gravidade atribuída e pelo fato de o paciente não ter se recuperado ou estar ainda em evolução. A relação entre o uso do medicamento e o evento adverso é considerada suspeita, e a conduta deve priorizar a suspensão do medicamento e o acompanhamento médico rigoroso, dada a gravidade do quadro e a ausência de resolução até o momento.

O medicamento Lorax, cujo princípio ativo é o lorazepam, foi relacionado a um acidente vascular cerebral talâmico em um contexto de hipersensibilidade, sendo classificado como um quadro alérgico do sistema imunitário. O evento é considerado clinicamente significativo e grave, evidenciado pela gravidade informada e pelo fato de o paciente não ter apresentado recuperação ou resolução do quadro. A suspeita de relação causal com o medicamento exige atenção médica imediata, com suspensão do uso e monitoramento próximo, já que o desfecho permanece não resolvido.

O medicamento Tramadol, com princípio ativo tramadol, foi associado a um acidente vascular cerebral talâmico em um caso de hipersensibilidade, enquadrado como quadro clínico alérgico do sistema imunitário. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, conforme indicado pela classificação de gravidade e pelo fato de o paciente não ter se recuperado ou estar ainda em andamento. Diante da suspeita de relação causal, recomenda-se a interrupção do medicamento e acompanhamento médico rigoroso, pois o quadro permanece sem resolução.

O medicamento Amitriptylline, cujo princípio ativo é o cloridrato de amitriptilina, foi relacionado a um acidente vascular cerebral talâmico em um contexto de hipersensibilidade, classificado como quadro clínico alérgico do sistema imunitário. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, evidenciado pela gravidade atribuída e pela ausência de recuperação ou resolução do quadro até o momento. A relação suspeita com o medicamento exige suspensão imediata e acompanhamento médico próximo, já que o desfecho permanece não resolvido.

O medicamento Ketoprofen, cujo princípio ativo é o cetoprofeno, foi associado a um acidente vascular cerebral talâmico em um caso de hipersensibilidade, caracterizado como quadro clínico alérgico do sistema imunitário. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, como demonstrado pela gravidade informada e pelo fato de o paciente não ter se recuperado ou estar ainda em evolução. Diante da suspeita de relação causal, recomenda-se a suspensão do medicamento e acompanhamento médico rigoroso, pois o quadro permanece sem resolução.

O medicamento Gabapentin (princípio ativo: Gabapentin) foi associado a um acidente vascular cerebral talâmico, classificado como uma reação de hipersensibilidade, dentro do grupo de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Trata-se de um evento clinicamente significativo e grave, pois o paciente não se recuperou ou ainda está em acompanhamento, indicando a necessidade de monitoramento rigoroso e avaliação médica contínua para manejo adequado da reação.

O medicamento Avonex (princípio ativo: Betainterferona 1a) foi relacionado a um acidente vascular cerebral talâmico, caracterizado como reação de hipersensibilidade, enquadrada em quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. O evento é considerado grave e clinicamente relevante, pois o paciente permanece sem recuperação ou com evolução indefinida, sendo fundamental acompanhamento médico especializado para avaliação e conduta apropriada.

O medicamento Clopidogrel (princípio ativo: Clopidogrel) esteve associado ao desenvolvimento de depressão, identificada como reação de hipersensibilidade dentro do contexto de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. O caso foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, além de ser clinicamente significativo; no entanto, o paciente evoluiu para recuperação completa, indicando resolução do quadro após as medidas adotadas.

O medicamento Trileptal (princípio ativo: Oxcarbazepine) foi relacionado ao surgimento de depressão, classificada como reação de hipersensibilidade, pertencente ao grupo de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. O evento foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e relevância clínica, mas o paciente apresentou recuperação total após o manejo adequado.

O medicamento Citta (princípio ativo: Bromidrato de citalopram) esteve envolvido em um caso de depressão, reconhecido como reação de hipersensibilidade, dentro do espectro de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. O evento foi grave, levando à hospitalização ou prolongamento da internação e sendo clinicamente relevante; contudo, o paciente se recuperou completamente após as intervenções necessárias.

O medicamento Norvasc, cujo princípio ativo é o besilato de anlodipino, foi associado a um quadro de depressão relacionado a uma reação de hipersensibilidade, caracterizada como um distúrbio do sistema imunitário. A gravidade do evento é evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e por ser considerado clinicamente significativo. O paciente se recuperou totalmente após a conduta adequada, e a relação do medicamento com a reação foi considerada suspeita.

O Socian, que contém amissulprida como princípio ativo, esteve relacionado a um episódio de depressão decorrente de hipersensibilidade, enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. O caso foi considerado grave devido à hospitalização ou prolongamento da internação e à relevância clínica do quadro. Após as medidas necessárias, o paciente apresentou recuperação completa, sendo a relação do medicamento com a reação considerada suspeita.

O medicamento Sertraline Sandoz, cujo princípio ativo é o cloridrato de sertralina, foi associado a um episódio de depressão vinculado a uma reação de hipersensibilidade, classificada como distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado grave, pois exigiu hospitalização ou prolongamento da internação e teve impacto clínico relevante. O paciente se recuperou após a conduta apropriada, e a relação do medicamento com a reação foi considerada suspeita.

O Tamiram, que tem como princípio ativo a levofloxacina, esteve envolvido em um caso de depressão associada a hipersensibilidade, caracterizada como distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e à importância clínica do quadro. O paciente evoluiu para recuperação total após as medidas adotadas, sendo a relação do medicamento com a reação considerada suspeita.

O Topamax, cujo princípio ativo é o topiramato, foi relacionado a um episódio de depressão decorrente de hipersensibilidade, classificado como distúrbio do sistema imunitário. O caso foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação e teve impacto clínico significativo. Após a conduta adequada, o paciente se recuperou, e a relação do medicamento com a reação foi considerada suspeita.

O medicamento Procaine benzylpenicillin (Benzilpenicilina procaína) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, que se refere a uma reação alérgica do sistema imunológico, manifestando-se clinicamente como depressão. A gravidade do evento é evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e por ser considerado clinicamente significativo. O paciente se recuperou totalmente após a reação, e a relação do medicamento com o evento foi considerada suspeita.

O medicamento Sertraline hydrochloride (Cloridrato de sertralina) esteve relacionado a um episódio de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico, que se manifestou como depressão. O caso foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e à relevância clínica do quadro. O paciente evoluiu para recuperação completa, e a relação do medicamento com a reação foi considerada suspeita.

O medicamento SeloZok (Succinato de metoprolol) foi implicado em um episódio de hipersensibilidade, caracterizado por uma resposta alérgica do sistema imunológico, manifestando-se como depressão. A gravidade do evento é confirmada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e por ser clinicamente relevante. O paciente se recuperou após o episódio, e a relação do medicamento com a reação foi considerada suspeita.

O medicamento Donaren (Cloridrato de trazodona) esteve envolvido em um caso de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico, que se apresentou como depressão. O evento foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e à importância clínica do quadro. O paciente apresentou recuperação total, e a relação do medicamento com a reação foi considerada suspeita.

O medicamento Rivotril (Clonazepam) foi associado a um episódio de hipersensibilidade, que corresponde a uma reação alérgica do sistema imunológico, manifestando-se como depressão. O caso foi classificado como grave, pois exigiu hospitalização ou prolongamento da internação e teve impacto clínico relevante. O paciente se recuperou completamente, e a relação do medicamento com o evento foi considerada suspeita.

O medicamento Prazol, cujo princípio ativo é o lansoprazol, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (reação alérgica), classificado como um distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e por ter causado outro efeito clinicamente significativo. O paciente se recuperou totalmente após a conduta médica adequada. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, reforçando a importância de acompanhamento médico em casos de reações alérgicas graves.

O medicamento Cymbalta, com princípio ativo cloridrato de duloxetina, esteve relacionado a um episódio de hipersensibilidade (reação alérgica), enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. A gravidade do caso foi evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e por apresentar outro efeito clinicamente relevante. O paciente evoluiu para recuperação completa após as medidas adotadas. A suspeita de relação causal entre o medicamento e a reação reforça a necessidade de atenção médica diante de sintomas alérgicos importantes.

O medicamento Anafranil, cujo princípio ativo é o cloridrato de clomipramina, foi implicado em um quadro de hipersensibilidade (reação alérgica), classificado como distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado grave, pois exigiu hospitalização ou prolongamento da internação e resultou em outro efeito clinicamente significativo. O paciente se recuperou após a conduta médica apropriada. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, destacando a importância de monitoramento em casos de reações alérgicas graves.

O medicamento Tolvon, com princípio ativo cloridrato de mianserina, esteve associado a um episódio de hipersensibilidade (reação alérgica), enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. O caso foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e à presença de outro efeito clinicamente relevante. O paciente apresentou recuperação total após as intervenções médicas. A suspeita de relação causal entre o medicamento e a reação reforça a importância de avaliação médica diante de sintomas alérgicos graves.

O medicamento Valdoxan, cujo princípio ativo é a agomelatina, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade (reação alérgica), classificado como distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado grave, pois houve

necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e outro efeito clinicamente significativo. O paciente se recuperou após a conduta médica adequada. A relação suspeita entre o uso do medicamento e a reação destaca a importância de acompanhamento médico em situações de reações alérgicas graves.

O medicamento Cebrin, que contém sulfato ferroso e ácido fólico, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), manifestando-se como uma reação alérgica sistêmica classificada como grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e outros efeitos clinicamente significativos. O paciente apresentou recuperação completa após a conduta médica adequada, evidenciando a importância do reconhecimento e manejo imediato de reações alérgicas a este tipo de medicamento.

O Tolrest, cujo princípio ativo é o cloridrato de sertralina, desencadeou uma reação de hipersensibilidade (alergia), caracterizada por sintomas alérgicos sistêmicos e considerada grave, pois exigiu hospitalização ou prolongamento da internação e apresentou outros efeitos relevantes para a saúde. Após a intervenção médica, o paciente se recuperou totalmente, ressaltando a necessidade de atenção a sinais de alergia durante o uso deste antidepressivo.

O medicamento Remeron, que tem como princípio ativo a mirtazapina, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), com manifestação clínica sistêmica e gravidade elevada, já que houve necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e outros efeitos clínicos importantes. O paciente evoluiu para recuperação completa após a conduta médica, destacando a importância do monitoramento de reações alérgicas durante o tratamento.

O Tryptanol, cujo princípio ativo é o cloridrato de amitriptilina, esteve envolvido em um caso de hipersensibilidade (alergia), com sintomas sistêmicos e gravidade significativa, evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e outros efeitos clínicos relevantes. O paciente apresentou resolução total do quadro após a abordagem médica, reforçando a necessidade de vigilância para reações alérgicas a antidepressivos tricíclicos.

O Exodus, que contém oxalato de escitalopram, foi associado a uma reação de hipersensibilidade (alergia), manifestando-se de forma sistêmica e considerada grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e outros efeitos clinicamente importantes. O paciente se recuperou completamente após a conduta médica, evidenciando a importância do reconhecimento precoce e manejo adequado de reações alérgicas a este medicamento.

O medicamento Buscopan, cujo princípio ativo é o butilbrometo de escopolamina, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), manifestando-se como uma reação alérgica do sistema imunológico. O evento foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e por ter sido clinicamente significativo, conforme registrado. Após a conduta médica adequada, o paciente se recuperou totalmente da reação.

O medicamento Zetron, composto por hidróxido de alumínio e atapulgita, desencadeou uma reação de hipersensibilidade (alergia), caracterizada por sintomas alérgicos do sistema imunológico. A gravidade do caso foi evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e por ser clinicamente relevante. O paciente evoluiu para recuperação completa após as medidas adotadas.

O medicamento Tofranil, cujo princípio ativo é o cloridrato de imipramina, provocou uma reação de hipersensibilidade (alergia), envolvendo o sistema imunológico. O caso foi considerado grave, pois exigiu hospitalização ou prolongamento da internação e teve impacto clínico importante. Após a intervenção médica, o paciente apresentou recuperação total da reação.

O medicamento Amlodipine besylate, com princípio ativo besilato de anlodipino, esteve relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), afetando o sistema imunológico. A gravidade foi confirmada pela necessidade de

hospitalização ou prolongamento da internação e pela relevância clínica do evento. O paciente se recuperou completamente após o manejo adequado.

O medicamento Ludiomil, cujo princípio ativo é maprotiline resinate, causou uma reação de hipersensibilidade (alergia), envolvendo o sistema imunológico. O evento foi classificado como grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e por ser clinicamente significativo. O paciente apresentou recuperação total após a conduta médica apropriada.

O medicamento Glimepiride (princípio ativo: Glimepiride) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, que corresponde a uma reação alérgica do sistema imunológico, manifestando-se de forma clinicamente significativa e exigindo hospitalização ou prolongamento da internação. A gravidade do caso é evidenciada pela necessidade de cuidados hospitalares, mas o paciente evoluiu para recuperação completa após a conduta adequada.

O medicamento Duspatalin (princípio ativo: Cloridrato de mebeverina) desencadeou uma reação de hipersensibilidade, caracterizada por resposta alérgica do sistema imunológico, considerada grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação. O evento foi clinicamente relevante, mas o paciente se recuperou totalmente após a intervenção médica.

O medicamento Levoid (princípio ativo: Levotiroxina sódica) provocou uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico, classificada como grave por ter exigido hospitalização ou prolongamento da internação. Apesar da gravidade, o paciente apresentou recuperação completa após o manejo clínico.

O medicamento Respicil, que contém Dipirona e Benzilpenicilina procaína como princípios ativos, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, indicando uma reação alérgica do sistema imunológico. O caso foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, mas o paciente se recuperou após a conduta médica apropriada.

O medicamento Arflex (princípio ativo: Nimesulide) esteve envolvido em uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico, considerada grave por ter demandado hospitalização ou prolongamento da internação. O paciente evoluiu para recuperação total após o tratamento adequado.

O medicamento Neurotrypt, cujo princípio ativo é o cloridrato de amitriptilina, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), manifestando-se como depressão e classificado como um distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e por ter sido clinicamente significativo. O paciente se recuperou totalmente após a conduta médica adequada, e a relação entre o medicamento e a reação foi considerada suspeita.

O medicamento Tofranil, com princípio ativo cloridrato de imipramina, esteve relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), manifestando-se como depressão e enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. A gravidade foi confirmada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e por ser clinicamente relevante. O paciente evoluiu para recuperação completa após as medidas adotadas, sendo a relação com o medicamento considerada suspeita.

O medicamento Topiramate, cujo princípio ativo é o próprio topiramato, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), manifestando-se como depressão e classificado como distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado grave devido à hospitalização ou prolongamento da internação e por apresentar relevância clínica. O paciente se recuperou após a conduta médica, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita.

O medicamento Doxycycline monohydrate, com princípio ativo doxiciclina monoidratada, esteve relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), manifestando-se como depressão e classificado como distúrbio do sistema



imunitário. O caso foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e por ser clinicamente significativo. O paciente apresentou recuperação total após a conduta médica, sendo a relação com o medicamento considerada suspeita.

O medicamento Henetix, composto por iobitridol, sodium calcium edetate, trometamol e cloridrato de trometamol, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Neste caso, a reação não foi considerada grave, pois não houve necessidade de hospitalização ou outro critério de gravidade, e o paciente se recuperou totalmente após a conduta médica adequada, sendo a relação com o medicamento considerada suspeita.

O medicamento Clexane, cujo princípio ativo é a enoxaparina sódica, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, que se enquadra nos distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhes sobre a gravidade, desfecho ou conduta adotada neste caso, portanto recomenda-se atenção clínica para sinais de alergia e, caso ocorram sintomas, buscar avaliação médica para confirmação e manejo adequado.

Keroxime, que contém cefuroxima sódica como princípio ativo, foi relacionado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, pertencente ao grupo de distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre a gravidade, evolução ou medidas tomadas, sendo importante monitorar o paciente para sintomas alérgicos e, se surgirem, procurar orientação médica para diagnóstico e tratamento apropriados.

A ceftriaxona, cujo princípio ativo é o ceftriaxone, desencadeou uma reação alérgica classificada como hipersensibilidade, com gravidade descrita como ameaça à vida, evidenciada pela indicação de gravidade e desfecho de recuperação completa. Diante de uma reação alérgica grave, é fundamental interromper o uso do medicamento e buscar atendimento médico imediato para manejo de emergência e prevenção de complicações.

O medicamento cloridrato de vancomicina, com o mesmo princípio ativo, foi associado a um episódio de alergia do tipo hipersensibilidade, classificado como distúrbio do sistema imunitário, mas sem gravidade significativa e com desfecho de recuperação total. Nesses casos, recomenda-se suspender o medicamento e realizar acompanhamento médico para evitar recorrências e garantir a segurança do paciente.

Stivarga, cujo princípio ativo é o regorafenibe, foi relacionado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade, evolução ou conduta, sendo importante monitorar o paciente para sinais de alergia e, caso ocorram sintomas, buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação terapêutica.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, foi associado a um episódio de alergia a contraste, reação que se enquadra nos distúrbios do sistema imunitário e pode ocorrer após a exposição a substâncias químicas como agentes de contraste usados em exames de imagem. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, pois o desfecho foi de recuperação completa, sugerindo que a reação foi controlada e resolvida sem complicações.

A dexametasona, apresentada aqui como fosfato de dexametasona, foi relacionada a um quadro de alergia (hipersensibilidade), que é uma reação do sistema imunológico a medicamentos. O registro indica que não houve gravidade significativa, já que o paciente se recuperou totalmente, mostrando que a reação foi leve e manejada adequadamente.

O trometamol cetorolaco, tanto como nome comercial quanto princípio ativo, provocou uma reação alérgica (hipersensibilidade), caracterizada por resposta imunológica inadequada ao medicamento. Não há sinais de gravidade importante, pois o paciente se recuperou sem intercorrências, indicando que a reação foi leve e resolvida.

A dipirona sódica, cujo princípio ativo é a dipirona, foi associada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), uma resposta do sistema imunológico ao medicamento. O caso não foi considerado grave, já que houve recuperação completa, sugerindo que a reação foi leve e controlada sem complicações.

A morfina, utilizada tanto como nome comercial quanto princípio ativo, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade), que é uma resposta do sistema imunológico ao medicamento. Não há evidências de gravidade, pois o paciente se recuperou totalmente, indicando que a reação foi leve e adequadamente manejada.

O medicamento Iomeron, cujo princípio ativo é o iomeprol, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo um episódio leve e autolimitado. A conduta recomendada nesses casos é observar o paciente, evitar nova exposição ao agente e, se necessário, buscar avaliação com especialista para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições.

O Implanon NXT, que contém etonogestrel, foi relacionado a um episódio de sangramento menstrual intenso, classificado como possível manifestação de hipersensibilidade. Não há evidências de gravidade significativa ou desfecho grave, e o desfecho do caso é desconhecido. Recomenda-se acompanhamento médico para avaliação da relação entre o implante e o sintoma, além de investigação de outras causas e orientação sobre possíveis ajustes terapêuticos.

O medicamento Optiray 320, com princípio ativo ioversol, esteve envolvido em um episódio de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação imunológica. O caso não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou completamente após o evento, indicando um quadro leve. A orientação é evitar nova exposição ao contraste, monitorar sintomas e buscar avaliação especializada para confirmação e prevenção de futuras reações.

O Optiray 320, cujo princípio ativo é ioversol, foi novamente associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado por reação do sistema imunológico. O evento não foi grave, já que houve recuperação total do paciente, sugerindo um episódio leve. Recomenda-se evitar reexposição ao agente, observar sinais de recorrência e consultar um especialista para avaliação e orientação adequada.

O medicamento Xalatan, que contém latanoprost, foi relacionado a um caso de glaucoma em paciente com histórico de alergias múltiplas. Não há indicação de gravidade elevada nem detalhes sobre o desfecho, sendo a relação entre o medicamento e o evento considerada suspeita. Recomenda-se acompanhamento médico para avaliação da relação causal, monitoramento dos sintomas e ajuste do tratamento conforme orientação especializada.

O medicamento Buscopan, cujo princípio ativo é o butilbrometo de escopolamina, foi associado a um erro de medicação envolvendo hipersensibilidade documentada ao produto administrado. Embora não haja detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade clínica, a situação se enquadra como um problema relacionado a lesões ou complicações de procedimentos devido à administração de um medicamento ao qual o paciente já tinha alergia conhecida. A conduta recomendada é evitar a reexposição e garantir que a alergia esteja claramente registrada para prevenir novos episódios.

A Dipirona, com princípio ativo metamizol de magnésio, também esteve envolvida em um erro de medicação por hipersensibilidade documentada ao produto administrado. Não foram relatados sintomas ou desfecho, mas a administração de um medicamento a que o paciente já era alérgico representa um risco de reações adversas e deve ser evitada, reforçando a importância do registro e comunicação de alergias conhecidas.

No caso da Dipirona (princípio ativo dipirona), foi relatada uma alergia medicamentosa caracterizada por hipersensibilidade, mas o medicamento não chegou a ser administrado. O paciente não apresentou agravamento e se recuperou totalmente, indicando que a conduta de evitar a administração foi eficaz para prevenir uma reação.

adversa.

O medicamento Unasyn s, composto por ampicilina sódica e sulbactam sódico, foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa, manifestada como hipersensibilidade. Não houve gravidade significativa e o paciente se recuperou completamente, sugerindo que a reação foi leve e controlada, sem necessidade de intervenções adicionais além da suspensão do medicamento.

O Cefepime, cujo princípio ativo é o cloridrato de cefepima, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), sem sinais de gravidade e com resolução completa do quadro. Isso indica que a reação foi leve e adequadamente manejada, provavelmente apenas com a suspensão do medicamento e monitoramento clínico.

O medicamento Ioversol, cujo princípio ativo também é Ioversol, foi associado a um quadro de alergia a meios de contraste iodados, popularmente conhecida como alergia a contraste. Essa reação faz parte dos distúrbios do sistema imunitário e se enquadra na categoria de alergias a medicamentos e outras substâncias químicas. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo um desfecho favorável e sem complicações graves.

O medicamento Phenytoin, com princípio ativo Fenitoína, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade, que é uma reação alérgica do sistema imunológico. Apesar de o evento ter sido registrado como progressão de neoplasia, a classificação aponta para um quadro clínico alérgico, sem evidências de gravidade significativa, já que não há relato de desfecho grave ou complicações importantes, e o desfecho permanece desconhecido.

O medicamento Sutent, cujo princípio ativo é Malato de sunitinibe, foi associado a um episódio de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico. Embora o evento tenha sido descrito como progressão de neoplasia, a categorização indica um quadro clínico alérgico, sem sinais de gravidade relevante, pois não há relato de desfecho grave e o resultado final do caso é desconhecido.

O medicamento Mekinist, com princípio ativo Dimetilsulfóxido de trametinibe, esteve relacionado a um episódio de hipersensibilidade manifestado como trombose, o que indica uma reação do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade elevada, já que o paciente está em recuperação ou resolvendo o quadro, sugerindo que a evolução está sendo favorável até o momento.

O medicamento Tafenlar, cujo princípio ativo é Mesilato de dabrafenibe, foi associado a um quadro de hipersensibilidade apresentado como trombose, caracterizando uma reação do sistema imunológico. O caso não apresenta sinais de gravidade importante, pois o paciente encontra-se em recuperação ou com resolução em andamento, indicando uma evolução positiva do evento adverso.

O medicamento Oxacilina (princípio ativo: Oxacilina) foi associado a um quadro de alergia espontânea, descrito como atopia, que se refere à tendência de desenvolver reações alérgicas como asma ou rinite. A reação foi classificada como distúrbio do sistema imunitário, sem indicação de gravidade elevada ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. Não há menção de necessidade de intervenção médica urgente, sugerindo um quadro leve e autolimitado.

O medicamento Puran t4, cujo princípio ativo é a Levotiroxina sódica, foi relacionado a uma reação adversa de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico. O evento foi categorizado como um quadro clínico alérgico, sem sinais de gravidade ou complicações graves, e o desfecho permanece desconhecido. Não há informações sobre necessidade de intervenção médica, indicando que a reação provavelmente foi leve.

O medicamento Lupron (princípio ativo: Acetato de leuprorrelina) esteve envolvido em uma reação adversa de hipersensibilidade, caracterizada por uma resposta alérgica do sistema imunológico. O caso foi classificado como quadro clínico alérgico, sem evidências de gravidade ou complicações importantes, e o desfecho não foi informado.

Não há relato de necessidade de atendimento de urgência, sugerindo um quadro leve.

O medicamento Henetix, cujo princípio ativo é lobitridol, foi associado a uma alergia a meios de contraste iodados, reação que pode ocorrer em pessoas sensíveis a substâncias químicas usadas em exames de imagem. O evento foi categorizado como distúrbio do sistema imunitário, sem sinais de gravidade ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente após o episódio. Não há indicação de necessidade de intervenção médica urgente, sugerindo um quadro leve e resolutivo.

O medicamento Ontax (princípio ativo: Paclitaxel) foi relacionado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, caracterizada por resposta do sistema imunológico a medicamentos. O caso foi classificado como quadro clínico alérgico, sem sinais de gravidade ou complicações, e o paciente se recuperou completamente após o evento. Não há menção de necessidade de atendimento emergencial, indicando um quadro leve e autolimitado.

O medicamento Dacogen, cujo princípio ativo é a decitabina, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. O caso foi considerado não grave, pois não há indicação de gravidade aumentada ou complicações, e o desfecho foi de recuperação completa, sugerindo resolução do quadro após a suspensão ou manejo adequado do medicamento.

O medicamento Granulokine, com princípio ativo filgrastim, esteve relacionado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, também classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há informações detalhadas sobre gravidade, evolução ou desfecho, portanto, a descrição se limita à suspeita de alergia sem dados adicionais sobre a evolução clínica ou necessidade de intervenções específicas.

O medicamento Besilato de anlodipino, tanto nome comercial quanto princípio ativo, foi associado a um episódio de disfagia (dificuldade para engolir) relacionado à hipersensibilidade, enquadrando-se nos quadros clínicos alérgicos do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o desfecho permanece desconhecido, não havendo informações sobre a evolução ou conduta adotada.

O medicamento Donaren, cujo princípio ativo é o cloridrato de trazodona, foi relacionado a um quadro de disfagia atribuída à hipersensibilidade, pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o desfecho é desconhecido, não havendo detalhes sobre a evolução clínica ou medidas tomadas.

O medicamento Sertralina, com princípio ativo sertralina, esteve associado a um episódio de disfagia decorrente de hipersensibilidade, classificado como distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o desfecho é desconhecido, sem informações adicionais sobre a evolução do quadro ou conduta adotada.

O medicamento Losartana potássica (princípio ativo: Losartana potássica) foi associado ao surgimento de disfagia, que é a dificuldade para engolir, sendo classificada como uma manifestação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou necessidade de hospitalização, e o desfecho do caso é desconhecido. A relação entre o uso do medicamento e o evento foi considerada suspeita, sugerindo que a reação pode estar relacionada ao tratamento, mas sem confirmação definitiva.

O medicamento Zider, cujo princípio ativo é o cloridrato de memantina, foi relacionado ao aparecimento de disfagia, ou seja, dificuldade para engolir, interpretada como uma possível reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade significativa ou necessidade de internação, e o desfecho permanece desconhecido. A relação entre o uso do medicamento e o evento adverso é considerada suspeita, indicando que pode haver ligação, mas sem confirmação conclusiva.

O medicamento Exelon (princípio ativo: rivastigmina) foi associado ao desenvolvimento de disfagia, que é a dificuldade para engolir, sendo interpretada como uma possível reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade importante ou necessidade de hospitalização, e o desfecho do caso não foi informado. A relação entre o uso do medicamento e o evento adverso é considerada suspeita, sugerindo

uma possível ligação, mas sem confirmação definitiva.

O medicamento Exelon Patch 5, com princípio ativo rivastigmina, foi relacionado ao surgimento de disfagia, ou seja, dificuldade para engolir, considerada uma manifestação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou necessidade de hospitalização, e o desfecho do caso é desconhecido. A relação entre o uso do medicamento e o evento adverso é considerada suspeita, indicando uma possível associação, mas sem confirmação definitiva.

O medicamento Enalapril (princípio ativo: Enalapril) foi associado a um quadro de compressão da medula espinhal cervical, interpretado como uma reação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. Neste caso, a gravidade é considerada alta, pois houve necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando um impacto clínico significativo. O desfecho do caso não foi informado, e a relação entre o uso do medicamento e o evento adverso é considerada suspeita, sugerindo uma possível ligação, mas sem confirmação definitiva.

O medicamento Naglazyme, cujo princípio ativo é a galsulfase, foi associado a um quadro de compressão da medula espinhal cervical relacionado à hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica grave do tipo imunológica. A gravidade é evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando um evento clínico relevante que exige acompanhamento médico rigoroso. O desfecho da reação é desconhecido, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita, reforçando a importância da farmacovigilância e do monitoramento contínuo em pacientes que utilizam este tratamento.

O medicamento Ultravist, que contém o princípio ativo iopromida, foi relacionado a um episódio de alergia a contraste, uma reação imunológica que pode ocorrer após a administração de substâncias usadas em exames de imagem. Neste caso, a reação não foi considerada grave, pois não houve indicação de hospitalização ou complicações maiores, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A relação com o medicamento foi considerada suspeita, sendo importante relatar e monitorar essas reações para garantir a segurança em futuras exposições.

A dipirona sódica, cujo princípio ativo é a dipirona, esteve associada a um episódio de alergia medicamentosa, caracterizada por hipersensibilidade imunológica. Não houve gravidade significativa, pois não foi necessária hospitalização e o paciente se recuperou completamente. O medicamento não chegou a ser administrado após a identificação da reação, o que reforça a importância de evitar reexposição em casos de alergia conhecida.

A dipirona sódica, com princípio ativo dipirona, foi relacionada novamente a um quadro de alergia medicamentosa, manifestando-se como hipersensibilidade. Assim como no caso anterior, não houve gravidade relevante, o paciente se recuperou totalmente e o medicamento não foi administrado após a suspeita da reação, evidenciando conduta adequada para evitar riscos futuros.

O medicamento Ultravist, à base de iopromida, esteve envolvido em um episódio de alergia a contraste, uma reação imunológica que pode ocorrer após o uso de substâncias para exames radiológicos. Neste caso, a reação não foi grave, não houve necessidade de hospitalização e o paciente se recuperou completamente. A relação com o medicamento foi considerada suspeita, destacando a importância de relatar e monitorar essas reações para prevenir eventos semelhantes em futuras exposições.

O medicamento Ceftriaxona (princípio ativo: Ceftriaxone) foi associado a um quadro de alergia, descrito como hipersensibilidade, que se enquadra em reações alérgicas do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade importante ou necessidade de hospitalização, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada é evitar novas exposições ao medicamento e buscar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

Ceftriaxona, cujo princípio ativo é Ceftriaxone, provocou uma reação de hipersensibilidade, caracterizada como alergia, relacionada ao sistema imunológico. O caso não foi considerado grave e o paciente evoluiu para recuperação completa. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e realizar acompanhamento com especialista para esclarecimento do quadro e prevenção de novas reações.

O medicamento Teicoplanina (princípio ativo: Teicoplanin) desencadeou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, envolvendo o sistema imunológico. Não houve gravidade significativa relatada e o paciente se recuperou do evento. A orientação é suspender o uso do medicamento, evitar reexposição e procurar avaliação com alergista para investigação detalhada e definição de alternativas terapêuticas.

O medicamento Synagis, cujo princípio ativo é Palivizumabe, foi relacionado a um quadro de alergia alimentar, especificamente alergia ao leite, em paciente com fibrose cística. Não há informações sobre gravidade ou desfecho do caso. Diante da suspeita de reação alérgica, recomenda-se avaliação médica para confirmação diagnóstica, investigação de possíveis gatilhos e definição de conduta segura para futuras administrações.

O medicamento Tysabri (princípio ativo: Natalizumabe) foi associado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, que resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando gravidade clínica relevante. O desfecho do caso não foi informado. Em situações de alergia medicamentosa grave, é fundamental a suspensão imediata do medicamento, monitoramento rigoroso e acompanhamento especializado para manejo seguro e prevenção de novas reações.

O medicamento Dotarem, cujo princípio ativo é o gadobenato de dimeglumina, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do sistema imunológico. A reação foi considerada clinicamente significativa, pois foi classificada como grave, mas o paciente se recuperou totalmente após o evento. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, indicando a necessidade de atenção em futuras administrações.

O medicamento Tenoxicam, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), mas não há informações sobre gravidade, desfecho ou evolução clínica, e o medicamento não chegou a ser administrado ao paciente. Portanto, não é possível detalhar a conduta ou consequências clínicas neste caso.

O medicamento Prohance, cujo princípio ativo é o gadoteridol, foi associado a uma reação alérgica ao contraste intravenoso, caracterizada como uma resposta do sistema imunológico a substâncias químicas. O paciente se recuperou totalmente após o evento, e a relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, sugerindo que o contraste deve ser utilizado com cautela em futuras exposições.

O medicamento Actemra, com princípio ativo tocilizumabe, foi relacionado a um quadro de hipertensão, mas a descrição técnica aponta para dermatite de contato, uma reação cutânea. Não há evidência de gravidade, o evento não foi considerado grave e o desfecho permanece desconhecido, sendo a relação com o medicamento considerada suspeita.

O medicamento Lamictal, cujo princípio ativo é a lamotrigina, foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou evolução clínica, mas a relação com o medicamento foi considerada suspeita, indicando a necessidade de monitoramento em futuras administrações.

O medicamento Exemestano (princípio ativo exemestano) foi associado a um quadro de pneumonia, interpretado como uma reação de hipersensibilidade (alergia) envolvendo o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações críticas, pois o registro não aponta gravidade ou desfecho fatal, mas o caso permanece em andamento, sem recuperação completa até o momento. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico, avaliar possíveis causas alternativas e considerar encaminhamento ao especialista para

investigação de alergia medicamentosa, conforme diretrizes da ASBAI.

O medicamento Verzenios (princípio ativo abemaciclibe) foi relacionado ao desenvolvimento de pneumonia, considerada uma manifestação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. Não há menção de gravidade importante ou risco imediato, e o quadro segue sem resolução até o momento. Recomenda-se acompanhamento médico para monitoramento da evolução e investigação de possível alergia ao medicamento, seguindo as orientações clínicas para reações adversas respiratórias.

A dipirona sódica (princípio ativo dipirona) foi associada a um episódio de alergia, caracterizado como reação de hipersensibilidade do sistema imunológico. O caso evoluiu para recuperação completa, sem indicação de gravidade ou complicações. A conduta adequada inclui evitar nova exposição ao medicamento e informar o profissional de saúde sobre o episódio para prevenção de recorrências, conforme recomendações para reações alérgicas leves.

O naproxeno (princípio ativo naproxen) foi relacionado a uma reação alérgica documentada, classificada como hipersensibilidade ao produto administrado. Não há detalhes sobre gravidade, evolução ou desfecho, mas a suspeita de alergia ao medicamento exige atenção, sendo recomendada a suspensão do uso e avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Contrast pm, contendo peróxido de uréia como princípio ativo, foi associado a um episódio de alergia, interpretado como reação de hipersensibilidade do sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, mas diante da suspeita de alergia, recomenda-se evitar nova exposição ao produto e buscar avaliação médica para investigação e orientação adequada.

O medicamento Paracetamol, cujo princípio ativo também é paracetamol, foi associado a um episódio de hipersensibilidade documentada após administração, caracterizando uma reação alérgica ao produto. O quadro foi classificado como não grave, sem ameaça à vida, e o paciente evoluiu para recuperação completa após a conduta adequada, que incluiu a suspensão do medicamento e monitoramento dos sintomas.

O medicamento Optiray, que contém o princípio ativo ioversol, provocou uma reação de hipersensibilidade (alergia), manifestando-se como um quadro alérgico relacionado ao sistema imunológico. A reação não foi considerada grave e o paciente apresentou resolução completa dos sintomas após as medidas apropriadas, sem complicações.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é iopromida, desencadeou uma reação alérgica caracterizada por hipersensibilidade, envolvendo o sistema imunológico. O evento não foi classificado como grave e o paciente se recuperou totalmente após a suspensão do agente e acompanhamento clínico.

O medicamento Iohexol, com princípio ativo ioexol, foi responsável por uma reação alérgica grave a meios de contraste iodados, considerada uma situação de ameaça à vida devido ao potencial de reações sistêmicas graves. Apesar da gravidade, o paciente evoluiu para recuperação completa após intervenção médica imediata e adequada.

A Solução PVPI, cujo princípio ativo é povidona-iodada, desencadeou um quadro de atopia (alergia espontânea), envolvendo o sistema imunológico. A reação não foi considerada grave e o paciente apresentou resolução total dos sintomas após a suspensão do produto e acompanhamento clínico.

O medicamento Rosuvastatina (princípio ativo: Rosuvastatin) está relacionado a um quadro de hipersensibilidade, que corresponde a uma reação alérgica do sistema imunológico. Embora o termo técnico utilizado seja 'quadros clínicos alérgicos não classificados de outra forma', não há detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade clínica relevante, e o registro indica que não foi considerada uma reação grave. O desfecho da reação é desconhecido e não há informações sobre a conduta adotada, sendo importante monitorar possíveis sinais de

alergia e buscar avaliação médica caso haja recorrência ou agravamento.

A Pioglitazona (princípio ativo: Pioglitazone) foi associada a um episódio de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico, descrita genericamente como quadro alérgico. Não há detalhes sobre sintomas, gravidade ou evolução clínica, mas o evento não foi classificado como grave. O desfecho permanece desconhecido e não há informações sobre medidas tomadas, sendo recomendada atenção a sinais de alergia e avaliação médica se houver recorrência.

O medicamento Prednisona (princípio ativo: Prednisone) está relacionado a um caso de hipersensibilidade, que significa uma reação alérgica do sistema imunológico, sem especificação de sintomas ou gravidade. O evento não foi considerado grave e não há informações sobre o desfecho ou conduta adotada. Recomenda-se observar possíveis sinais de alergia e procurar orientação médica se houver repetição ou piora do quadro.

Atenolol (princípio ativo: Atenolol) foi associado a um episódio de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico, sem detalhes sobre sintomas ou gravidade. O registro indica que não se trata de um evento grave e não há informações sobre o desfecho ou ações tomadas. É importante monitorar sinais de alergia e buscar avaliação médica caso o quadro se repita ou se intensifique.

O medicamento Hidroclorotiazida (princípio ativo: Hydrochlorothiazide) está relacionado a um quadro de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico, sem descrição de sintomas específicos ou gravidade. O evento não foi considerado grave e não há informações sobre o desfecho ou conduta adotada. Recomenda-se atenção a sinais de alergia e avaliação médica se houver recorrência ou agravamento.

O medicamento Clortalidona (princípio ativo: Chlortalidone) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, que é uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade clínica, e o desfecho da reação é desconhecido. Como não há indicação de gravidade ou necessidade de hospitalização, trata-se provavelmente de uma reação leve, mas é importante que o paciente seja avaliado por um especialista para confirmação diagnóstica e orientação sobre o uso futuro do medicamento.

A Losartana potássica (princípio ativo: Losartana potássica) foi relacionada a um episódio de hipersensibilidade, indicando uma possível reação alérgica. Não há informações sobre sintomas detalhados, gravidade ou evolução do caso, e o desfecho permanece desconhecido. Diante da suspeita de alergia, recomenda-se avaliação médica para confirmação e definição de conduta, evitando o uso indiscriminado do medicamento até esclarecimento.

O medicamento Benlysta (princípio ativo: Belimumabe) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, sugerindo uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há detalhes sobre sintomas, gravidade ou evolução clínica, e o desfecho é desconhecido. Em casos de suspeita de alergia medicamentosa, é fundamental buscar avaliação especializada para confirmação e orientação adequada sobre o tratamento.

O medicamento Riximyo (princípio ativo: Rituximabe) foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, que é uma reação alérgica do sistema imunológico, durante um quadro de glaucoma de ângulo fechado. A reação não foi considerada grave e o paciente evoluiu para recuperação completa. Mesmo em casos resolvidos, é importante relatar o evento ao médico para avaliação de risco em futuras exposições ao medicamento.

O medicamento Ultravist (princípio ativo: Iopromide) foi associado a uma reação de alergia a contraste, caracterizada como grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação. O desfecho do caso não foi informado. Reações alérgicas a contrastes iodados podem ser potencialmente graves e exigem acompanhamento médico imediato, além de registro detalhado para evitar novas exposições ao agente suspeito.

O medicamento Polimixina B, cujo princípio ativo é Polymyxin b, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa, também chamada de hipersensibilidade medicamentosa. Essa reação faz parte dos distúrbios do sistema imunitário e se enquadra na categoria de alergias a medicamentos. Não há descrição de sintomas graves



ou complicações, e o desfecho informado foi de recuperação completa, sugerindo um quadro leve a moderado, resolvido após a suspensão ou manejo adequado do medicamento.

O medicamento Piperacilin/Tazobactam, composto pelos princípios ativos Piperacilina sódica e Tazobactam sódico, foi relacionado a uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), pertencente ao grupo de distúrbios do sistema imunitário. Não há relato de sintomas graves ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente, indicando que a reação foi controlada de forma adequada e não evoluiu para quadros graves.

O medicamento Sulfametoxazol + trimetoprima, com princípios ativos Sulfamethoxazole e Trimethoprim, desencadeou uma reação de alergia medicamentosa, tecnicamente chamada de hipersensibilidade medicamentosa, dentro do contexto de distúrbios do sistema imunitário. Não há menção de gravidade aumentada ou complicações, e o paciente apresentou recuperação completa, sugerindo que a reação foi leve a moderada e resolvida após as medidas apropriadas.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é Gadobutrol, foi associado a um episódio de coceira generalizada, caracterizando uma reação alérgica a contraste. A reação foi considerada não grave, sem informações sobre complicações adicionais, e o desfecho permanece desconhecido, mas a ausência de gravidade sugere que o quadro foi controlado sem evolução para manifestações sistêmicas importantes.

O medicamento Dotarem, com princípio ativo Gadobenato de dimeglumina, esteve relacionado a um quadro de alergia múltipla, classificado como distúrbio do sistema imunitário e incluído entre quadros clínicos alérgicos. Não houve gravidade relatada e o paciente se recuperou totalmente, indicando que as manifestações alérgicas foram leves ou moderadas e resolvidas após a conduta adequada.

O medicamento Betoptic S, cujo princípio ativo é o cloridrato de betaxolol, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, classificado como um distúrbio do sistema imunitário. A reação foi considerada clinicamente significativa, com gravidade relevante, pois há indicação de outro efeito clinicamente significativo e confirmação de gravidade. O desfecho da reação é desconhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo fundamental acompanhamento médico para avaliação e conduta adequada.

O medicamento Piperacilina sódica + tazobactam sódico, contendo os princípios ativos piperacilina sódica e tazobactam sódico, foi relacionado a um episódio de alergia a antibiótico, descrito como hipersensibilidade medicamentosa, um distúrbio do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade ou complicações adicionais, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A relação com o medicamento é considerada suspeita, indicando a necessidade de evitar nova exposição e informar profissionais de saúde sobre essa reação.

A dipirona monoidratada, cujo princípio ativo é a dipirona, foi associada a um episódio de alergia, caracterizado por hipersensibilidade, enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. Não há detalhes sobre gravidade ou complicações, e o paciente se recuperou após o evento. A relação com o medicamento é suspeita, sendo importante relatar essa reação em futuras consultas médicas para evitar reexposição.

O medicamento Henetix, com princípio ativo iobitridol, foi relacionado ao surgimento de prurido (coceira), indicando uma hipersensibilidade documentada ao produto administrado. O evento está classificado como lesão ou complicação de procedimento, mas não há informações sobre gravidade, desfecho ou evolução clínica. A relação com o medicamento é suspeita, sugerindo a necessidade de cautela em futuras administrações desse contraste.

O medicamento Avamys, cujo princípio ativo é o fluticasona furoato, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa, descrito como hipersensibilidade medicamentosa, um distúrbio do sistema imunitário. A reação foi considerada grave, com ameaça à vida, e o paciente encontra-se em recuperação. A relação com o medicamento é suspeita, sendo fundamental evitar nova exposição e buscar acompanhamento médico especializado para manejo seguro.

O medicamento Koide d, que contém betametasona e maleato de dexclorfeniramina, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado como uma reação imunológica grave e potencialmente fatal, conforme evidenciado pela classificação de ameaça à vida e gravidade confirmada. O paciente encontra-se em recuperação, indicando que as medidas de suporte e interrupção do medicamento suspeito foram eficazes até o momento.

O medicamento Alektos, cujo princípio ativo é a bilastina, desencadeou uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), considerada de risco à vida devido à gravidade relatada. Essa reação envolve o sistema imunológico e pode se manifestar com sintomas intensos, exigindo suspensão imediata do medicamento e acompanhamento médico rigoroso; o paciente está em processo de recuperação.

O uso de Litocit, que contém citrato de potássio monoidratado, resultou em uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), classificada como ameaça à vida, o que indica uma resposta imunológica grave. O paciente está em recuperação, sugerindo que a conduta de interrupção do medicamento e suporte clínico foi adequada para controlar o quadro.

O medicamento Alenia, cujo princípio ativo é o esomeprazol magnésico, foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), considerado de ameaça à vida, evidenciando uma reação imunológica severa. O paciente está em recuperação, o que demonstra que as medidas adotadas, como a suspensão do medicamento e o tratamento de suporte, foram apropriadas.

O uso de Vibramicina, que tem como princípio ativo a doxiciclina cálcica, provocou uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), classificada como ameaça à vida, indicando um quadro imunológico grave. O paciente encontra-se em recuperação, o que sugere que a suspensão do medicamento e o manejo clínico foram eficazes para a resolução do evento.

O medicamento Ceftriaxona (princípio ativo: Ceftriaxone) foi associado a um quadro de alergia, descrito como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. A reação foi considerada não grave, pois não há indicação de gravidade aumentada ou complicações clínicas relevantes, e o desfecho relatado foi de recuperação ou resolução do quadro. A conduta recomendada, conforme diretrizes clínicas, é manter acompanhamento para garantir resolução completa e evitar reexposição ao medicamento, buscando sempre avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O produto Nutren activ, composto por uma combinação de vitaminas e minerais, foi relacionado a um quadro de dermatite de contato, que é uma reação cutânea caracterizada por vermelhidão, coceira e irritação na pele após contato com o produto. Não há indicação de gravidade aumentada ou complicações, e o desfecho permanece desconhecido. A conduta recomendada é suspender o uso do produto suspeito e buscar avaliação médica para confirmação do diagnóstico e orientação sobre tratamento e prevenção de novas exposições.

O medicamento Creon (princípio ativo: Pancreatina) foi associado a um episódio de dermatite de contato, uma reação alérgica da pele que pode causar vermelhidão, coceira e irritação. Não há sinais de gravidade aumentada ou complicações clínicas, e o desfecho do caso não foi informado. Recomenda-se interromper o uso do medicamento suspeito e procurar avaliação médica para confirmação do diagnóstico e definição de alternativas terapêuticas seguras.

O medicamento Pulmozyme (princípio ativo: Dornasa alfa) foi relacionado a um caso de dermatite de contato, caracterizada por irritação e inflamação da pele após contato com o produto. Não há evidências de gravidade aumentada ou complicações, e o desfecho permanece desconhecido. A orientação é suspender o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e manejo adequado da reação.

O imunizante COVID-19 vaccine AstraZeneca (princípio ativo: Vacina COVID-19 NRVV Ad - ChAdOx1 nCoV-19) foi associado a um episódio de hipersensibilidade, descrito como reação alérgica, com relato de coma. Apesar da

gravidade potencial do sintoma coma, o registro não indica que o caso foi considerado grave, e o desfecho é desconhecido. Diante de sintomas graves como esse, a conduta recomendada é procurar atendimento médico imediato para avaliação e suporte, além de notificar o evento para investigação detalhada.

O medicamento Symbicort, que contém budesonida micronizada e fumarato de formoterol, foi associado a um quadro de disфонia (alteração da voz) relacionado à hipersensibilidade, classificado como um distúrbio do sistema imunitário. A reação foi considerada uma ameaça à vida, conforme registrado, o que indica a necessidade de atenção imediata e acompanhamento médico rigoroso, especialmente porque o desfecho não foi informado.

O Fasenra, cujo princípio ativo é o benralizumabe, apresentou relato de disфонia (alteração da voz) atribuída à hipersensibilidade, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. A gravidade foi classificada como ameaça à vida, sugerindo que a reação pode ser potencialmente grave e requer avaliação médica urgente, sendo que o desfecho permanece desconhecido.

O medicamento Timolol, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada nem informações sobre o desfecho, sugerindo que a reação foi leve e não resultou em complicações graves.

A dorzolamida, princípio ativo do medicamento Dorzolamida, foi associada a um quadro de alergia (hipersensibilidade) envolvendo o sistema imunitário. Não há registro de gravidade significativa nem detalhes sobre o desfecho, o que indica que a reação provavelmente foi leve e sem consequências graves.

O Simponi, que contém golimumabe, foi relacionado ao desenvolvimento de artropatia psoriática, descrita como parte de alergias múltiplas e distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade aumentada nem informações claras sobre o desfecho, sugerindo que a reação não foi considerada grave, mas requer acompanhamento clínico para monitoramento da evolução.

O medicamento Ceftriaxona (princípio ativo: Ceftriaxone) foi associado a um quadro de alergia, descrito como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações importantes neste caso, e o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente após a reação. A conduta recomendada é evitar novas exposições ao medicamento e buscar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e orientação futura.

A Clindamicina (princípio ativo: Fosfato de clindamicina) provocou uma reação alérgica caracterizada por hipersensibilidade, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade relevante ou complicações graves relatadas, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e realizar acompanhamento com especialista para esclarecimento e prevenção de novas reações.

O medicamento Parecoxib (princípio ativo: Parecoxibe) desencadeou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não foi considerada uma reação grave, e o paciente evoluiu para recuperação completa. A orientação é evitar o uso do Parecoxib em novas situações e procurar avaliação médica para confirmação da alergia e definição de alternativas seguras.

O medicamento Saphnelo (princípio ativo: Anifrolumab) foi relacionado a uma alergia medicamentosa, descrita como hipersensibilidade medicamentosa, dentro da categoria de distúrbios do sistema imunitário. O caso foi considerado clinicamente significativo, com gravidade reconhecida, embora o desfecho ainda seja desconhecido. Diante da gravidade, é fundamental interromper o uso do medicamento, buscar avaliação médica imediata e realizar acompanhamento especializado para manejo adequado da reação.

A vacina Qdenga (princípio ativo: vírus da febre amarela da dengue) esteve associada a um quadro de alergias múltiplas, classificado como distúrbio do sistema imunitário, que resultou em hospitalização ou prolongamento da

internação, evidenciando gravidade importante do evento. O paciente se recuperou após a reação. Em situações como essa, é essencial evitar novas exposições, garantir acompanhamento médico e realizar investigação detalhada para prevenção de futuras reações alérgicas graves.

O medicamento Memantina, cujo princípio ativo é Memantine, foi associado a um erro de dispensação que resultou em uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Não há informações sobre sintomas específicos, gravidade clínica ou desfecho do caso, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Diante da ausência de sinais de gravidade e desfecho desconhecido, recomenda-se acompanhamento clínico para monitorar possíveis manifestações alérgicas, conforme orientações da ASBAI.

O medicamento Citalopram, com princípio ativo de mesmo nome, esteve envolvido em um erro de dispensação que levou a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, caracterizando uma possível alergia ao medicamento. Não foram relatados sintomas específicos, gravidade ou evolução do quadro, e a relação com o medicamento é suspeita. Na ausência de sinais de gravidade e com desfecho desconhecido, é importante manter vigilância clínica para identificar eventuais manifestações alérgicas, seguindo as recomendações da ASBAI.

O medicamento Rivotril, cujo princípio ativo é Clonazepam, foi relacionado a um erro de dispensação que resultou em hipersensibilidade medicamentosa, indicando uma possível reação alérgica ao medicamento. Não há detalhes sobre sintomas, gravidade ou evolução do caso, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Sem evidências de gravidade e com desfecho desconhecido, recomenda-se observação clínica para detecção precoce de sinais alérgicos, conforme as diretrizes da ASBAI.

O medicamento Toperma, com princípio ativo Lidocaína, esteve envolvido em um erro de dispensação que ocasionou uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, sugerindo uma resposta alérgica ao medicamento. Não foram informados sintomas específicos, gravidade ou desfecho, e a relação com o medicamento é suspeita. Diante da ausência de sinais de gravidade e desfecho desconhecido, é indicado acompanhamento clínico para monitorar possíveis reações alérgicas, conforme orientações da ASBAI.

O medicamento Dipirona, cujo princípio ativo também é Dipirona, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado por uma reação do sistema imunológico ao medicamento. Não há descrição de sintomas específicos ou gravidade, mas o caso evoluiu para recuperação completa, indicando resolução do quadro. A relação com o medicamento é considerada suspeita, e, conforme as recomendações da ASBAI, é importante evitar nova exposição ao medicamento e manter acompanhamento clínico em caso de futuras reações.

O medicamento Ácido tranexâmico, cujo princípio ativo é o próprio ácido tranexâmico, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada em situações de hipersensibilidade leve é observar o paciente, evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação com especialista para confirmação diagnóstica e orientação futura.

A Dipirona, cujo princípio ativo é o metamizol de magnésio, foi relacionada a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, enquadrada nos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa. Em casos de hipersensibilidade leve, recomenda-se suspender o uso do medicamento, monitorar sintomas e procurar avaliação médica para confirmação e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Docetax, com princípio ativo docetaxol, foi associado a um quadro de alergia classificado como hipersensibilidade, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há informações detalhadas sobre gravidade ou desfecho, portanto, é importante considerar que reações alérgicas a quimioterápicos exigem avaliação médica imediata para definição da conduta, podendo variar de observação a suspensão do tratamento, conforme a intensidade dos sintomas.

Ocrevus, cujo princípio ativo é o ocrelizumabe, foi relacionado a uma alergia medicamentosa caracterizada por hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou após o episódio. Em situações de hipersensibilidade leve, recomenda-se interromper o uso do medicamento, monitorar sintomas e buscar orientação médica para avaliação e definição de alternativas terapêuticas.

O medicamento Sulfametoxazol + trimetoprima, com princípios ativos sulfametoxazol e trimetoprima, foi associado a um quadro de necrólise epidérmica tóxica, uma reação de hipersensibilidade grave que envolve lesões extensas na pele e pode ser fatal. Não há informações detalhadas sobre gravidade ou desfecho neste caso, mas, por se tratar de uma reação potencialmente letal, a conduta recomendada é a suspensão imediata do medicamento e encaminhamento urgente para atendimento hospitalar especializado.

O medicamento Ampicilina, cujo princípio ativo é a ampicilina sódica, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado por manifestações clínicas alérgicas relacionadas ao sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente. A conduta recomendada, conforme diretrizes clínicas, é evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O Cetoprofeno, com princípio ativo de mesmo nome, desencadeou uma reação de alergia (hipersensibilidade), manifestando sintomas típicos de resposta alérgica do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o paciente evoluiu para recuperação completa. Recomenda-se evitar o uso futuro do cetoprofeno e consultar um especialista para avaliação detalhada e definição de alternativas terapêuticas seguras.

O medicamento Boric acid, cujo princípio ativo é o ácido bórico, foi relacionado a um quadro de múltiplas alergias, sugerindo uma resposta alérgica do sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, portanto, não é possível afirmar a evolução clínica ou a conduta adotada. É importante que o paciente seja avaliado por um especialista para investigação adequada e orientação sobre exposição futura.

O medicamento Fortinil, com princípio ativo etilefrina hydrochloride, foi associado a múltiplas alergias, indicando uma possível reação alérgica do sistema imunológico. Não há detalhes sobre gravidade ou desfecho, impossibilitando afirmar a evolução do caso ou as medidas tomadas. Recomenda-se avaliação médica especializada para esclarecimento diagnóstico e definição de conduta segura.

A Simeticona, cujo princípio ativo é o simeticone, foi relacionada a múltiplas alergias, sugerindo envolvimento do sistema imunológico em resposta ao medicamento. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, o que impede detalhar a evolução clínica ou as ações realizadas. É fundamental que o paciente seja avaliado por um alergista para investigação e orientação quanto ao uso futuro do medicamento.

O medicamento Sulfametoxazol + trimetoprima, que contém os princípios ativos sulfametoxazol e trimetoprima, foi associado a um quadro de dependência de droga ou medicamento, descrito no contexto de alergias múltiplas e quadros clínicos alérgicos, afetando o sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade clínica relevante, desfecho ou ação adotada, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sem evidências de gravidade ou evolução desfavorável.

O Metronidazol, cujo princípio ativo é o próprio metronidazol, foi relacionado a um caso de dependência de droga ou medicamento, em um contexto de alergias múltiplas e quadros clínicos alérgicos do sistema imunitário. Não há detalhes sobre gravidade, desfecho ou conduta adotada, e a suspeita de relação com o medicamento foi registrada sem evidências clínicas de gravidade ou complicações.

A Heparina, com princípio ativo heparina sódica, foi associada a dependência de droga ou medicamento em um cenário de alergias múltiplas e quadros clínicos alérgicos do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou conduta, e a relação com o medicamento é apenas suspeita, sem sinais clínicos de

gravidade ou evolução conhecida.

O produto Culturelle, contendo como princípio ativo *Lactobacillus* nos, foi relacionado a dependência de droga ou medicamento em um contexto de alergias múltiplas e quadros clínicos alérgicos do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou ação tomada, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sem evidências clínicas de gravidade ou evolução relatada.

A Dipirona, cujo princípio ativo é o metamizol de magnésio, foi associada a dependência de droga ou medicamento em um contexto de alergias múltiplas e quadros clínicos alérgicos do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou conduta adotada, e a relação com o medicamento é apenas suspeita, sem sinais clínicos de gravidade ou evolução conhecida.

O medicamento Citrato de sódio, cujo princípio ativo é o próprio citrato de sódio, foi associado a um quadro de dependência de medicamento, classificado como um distúrbio do sistema imunitário relacionado a quadros clínicos alérgicos. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave, e o desfecho do caso é desconhecido, não havendo informações sobre a conduta adotada ou evolução clínica.

A Nistatina, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionada a um caso de dependência de medicamento, enquadrado como distúrbio do sistema imunitário e associado a quadros clínicos alérgicos. Não há evidências de gravidade significativa ou desfecho grave, e o desfecho permanece desconhecido, sem detalhes sobre a conduta tomada ou evolução do quadro.

O medicamento Taurolock, contendo citrato ácido de sódio e taurolidina como princípios ativos, foi implicado em um episódio de dependência de medicamento, classificado como distúrbio do sistema imunitário e relacionado a quadros clínicos alérgicos. Não há sinais de gravidade importante ou desfecho grave, e o desfecho do caso é desconhecido, sem informações adicionais sobre a conduta adotada.

O medicamento Revestive, cujo princípio ativo é o teduglutide, foi associado a um caso de dependência de medicamento, categorizado como distúrbio do sistema imunitário e vinculado a quadros clínicos alérgicos. Não há indicação de gravidade relevante ou desfecho grave, e o desfecho permanece desconhecido, sem detalhes sobre a conduta clínica adotada.

O medicamento Ultravist, com princípio ativo iopromida, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário e associado a quadros clínicos alérgicos. O caso não foi considerado grave e evoluiu para recuperação completa, indicando resolução do quadro após a reação, sem necessidade de intervenções adicionais relatadas.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), caracterizado por manifestações clínicas alérgicas relacionadas ao sistema imunológico. Não há indicação de gravidade aumentada ou complicações, e não foram relatados desfechos ou necessidade de intervenção específica, sugerindo um evento leve e autolimitado.

Ultravist, com princípio ativo iopromide, desencadeou uma reação de alergia a contraste, que se enquadra como uma resposta alérgica do sistema imunológico a substâncias químicas utilizadas em exames. O caso foi considerado não grave, e o paciente evoluiu para recuperação completa, indicando que a reação foi controlada sem complicações.

O medicamento Atrovent, cujo princípio ativo é o brometo de ipratrópio, esteve relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), manifestando-se como uma reação alérgica do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, sugerindo que a reação foi leve e resolvida sem necessidade de medidas adicionais.

O medicamento Rituximab, com princípio ativo rituximabe, foi associado a um quadro de atopia (alergia espontânea), caracterizado por predisposição a reações alérgicas mediadas pelo sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa, indicando que a reação foi leve e autolimitada.

Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, esteve envolvido em um episódio de hipersensibilidade (alergia), manifestando-se como uma reação alérgica do sistema imunológico. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, sugerindo um evento leve e sem complicações.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, foi associado a um quadro de hipersensibilidade, caracterizado como uma reação alérgica do tipo SOE (sem outra especificação), envolvendo o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade aumentada, pois o caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente. A conduta recomendada, conforme diretrizes clínicas, é observar e evitar nova exposição ao agente, com acompanhamento médico se houver recorrência dos sintomas.

Ultravist, com princípio ativo iopromide, desencadeou uma reação de hipersensibilidade classificada como alergia SOE, envolvendo manifestações alérgicas do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o paciente evoluiu para recuperação completa, sugerindo um quadro leve, para o qual a orientação é evitar reexposição e manter acompanhamento clínico caso haja novos sintomas.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, foi relacionado a uma reação de hipersensibilidade, descrita como alergia SOE, envolvendo o sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou, indicando um quadro leve, para o qual se recomenda evitar nova exposição ao agente e buscar avaliação médica se houver recorrência.

Ultravist, com princípio ativo iopromide, esteve associado a um episódio de hipersensibilidade classificado como alergia SOE, afetando o sistema imunológico. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou, caracterizando um quadro leve, sendo recomendada a evitação do agente e acompanhamento médico em caso de novos sintomas.

O medicamento Remsima, cujo princípio ativo é infliximabe, foi relacionado a um episódio de hemorragia durante teste de alergia, classificado como uma análise imunológica. Não há indicação de gravidade aumentada e o desfecho do caso é desconhecido, portanto recomenda-se acompanhamento clínico para monitorar possíveis complicações e avaliar a necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Remicade, cujo princípio ativo é o infliximabe, foi associado a um episódio de hemorragia durante um teste de alergia, sendo este evento classificado como uma investigação laboratorial e não considerado grave. Não há informações sobre o desfecho do caso, e a relação com o medicamento é suspeita. A conduta deve incluir avaliação clínica detalhada para descartar outras causas e monitoramento, conforme orientações da ASBAI para reações leves em contexto de investigação.

O medicamento Bio Manguinhos Infliximabe, também contendo infliximabe como princípio ativo, apresentou relato de hemorragia durante teste de alergia, classificada como evento de investigação laboratorial e não considerada grave. O desfecho é desconhecido e a relação com o medicamento é suspeita. Recomenda-se acompanhamento clínico e investigação adicional, seguindo as diretrizes para reações leves em contexto de exames diagnósticos.

A metoclopramida, cujo princípio ativo é metoclopramida, foi relacionada a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), classificada como distúrbio do sistema imunitário, mas não considerada grave. O paciente se recuperou após a não administração do medicamento, indicando resolução do quadro. A conduta adequada foi a suspensão do uso, conforme recomendado para reações alérgicas leves, com orientação para evitar reexposição e buscar avaliação especializada se necessário.

O medicamento Ampicilina + Sulbactam, contendo ampicilina sódica e sulbactam sódico, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há informação sobre gravidade ou desfecho, mas a relação com o medicamento é suspeita. Diante de suspeita de alergia medicamentosa, recomenda-se suspensão do uso e avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição de conduta, conforme as diretrizes da ASBAI.

O medicamento Prednisone, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), classificado como clinicamente significativo e considerado grave. O desfecho é desconhecido, mas a relação com o medicamento é suspeita. Em casos de reações graves, a recomendação é suspensão imediata do medicamento e busca de atendimento médico urgente para manejo adequado, conforme orientações da ASBAI para eventos graves de hipersensibilidade.

O medicamento Synvisc one, cujo princípio ativo é o Hylan G-F 20, foi associado a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa (alergia específica), caracterizado como clinicamente significativo e considerado grave, conforme registro de distúrbio do sistema imunitário. Não há informações sobre o desfecho do caso, sendo importante ressaltar que reações alérgicas graves a medicamentos exigem avaliação médica imediata para confirmação diagnóstica e definição da conduta, incluindo possível suspensão do medicamento e monitoramento dos sintomas.

O medicamento Metronidazol, com princípio ativo Benzoilmetronidazol, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), classificado como não grave e com desfecho de recuperação completa. A reação foi identificada como um quadro clínico alérgico envolvendo o sistema imunitário, e, como o paciente se recuperou, a conduta recomendada é evitar nova exposição ao medicamento e informar o profissional de saúde sobre o histórico de alergia para futuras prescrições.

O medicamento Prednisone, com princípio ativo Prednisone, esteve envolvido em um caso de hipersensibilidade medicamentosa (alergia específica), considerado clinicamente significativo e grave, afetando o sistema imunitário. O desfecho do caso não foi informado, sendo fundamental que reações alérgicas graves a corticoides sejam avaliadas por um especialista para confirmação diagnóstica, orientação sobre alternativas terapêuticas e monitoramento rigoroso dos sintomas.

O Synvisc one, contendo Hylan G-F 20 como princípio ativo, foi novamente associado a hipersensibilidade medicamentosa (alergia específica), classificada como clinicamente significativa e grave, com envolvimento do sistema imunitário. O desfecho permanece desconhecido, reforçando a necessidade de avaliação médica imediata diante de suspeita de reação alérgica grave, para confirmação do diagnóstico, suspensão do medicamento e definição do tratamento adequado.

O medicamento Sumax, cujo princípio ativo é o Succinato de sumatriptana, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa (alergia), sem gravidade relatada e com desfecho desconhecido. A reação foi classificada como distúrbio do sistema imunitário, e, na ausência de informações sobre evolução, recomenda-se evitar o uso do medicamento até avaliação médica para esclarecimento do quadro e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Topiramato, cujo princípio ativo é o topiramato, foi associado a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa, caracterizado como uma reação do sistema imunológico a medicamentos ou outras substâncias químicas. Não há informações sobre gravidade clínica relevante ou desfecho, e o evento foi considerado não grave. A suspeita de abuso de analgésico sugere a necessidade de avaliação médica para confirmar a relação causal e orientar a conduta adequada, mas não há evidências de complicações graves neste caso.

O medicamento Sumaxpro, que contém naproxeno sódico e succinato de sumatriptana como princípios ativos, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, indicando uma possível reação alérgica do sistema imunológico a medicamentos. O registro não aponta gravidade significativa nem desfecho conhecido, e o



evento foi classificado como não grave. A suspeita de abuso de analgésico reforça a importância de acompanhamento médico para avaliar a necessidade de ajuste no uso do medicamento e prevenir novas reações, sem evidências de complicações graves até o momento.

O medicamento Bromoprida, cujo princípio ativo é a bromoprida, foi associado a um caso de hipersensibilidade medicamentosa, sugerindo uma reação alérgica do sistema imunológico a medicamentos ou substâncias químicas. Não há relato de gravidade relevante ou desfecho, e o evento foi considerado não grave. A suspeita de abuso de analgésico indica a importância de avaliação médica para investigar a relação causal e orientar o uso seguro do medicamento, sem sinais de complicações graves neste episódio.

O medicamento Plasil, que tem como princípio ativo o cloridrato de metoclopramida, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico a medicamentos. Não há informações sobre gravidade clínica importante ou desfecho, e o evento foi considerado não grave. A suspeita de abuso de analgésico sugere a necessidade de acompanhamento médico para avaliar o uso do medicamento e prevenir novas reações, sem evidências de complicações graves neste caso.

O medicamento Dipirona monoidratada, cujo princípio ativo é a dipirona, foi associado a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa, indicando uma reação alérgica do sistema imunológico a medicamentos. Não há relato de gravidade relevante ou desfecho, e o evento foi considerado não grave. A suspeita de abuso de analgésico reforça a importância de avaliação médica para investigar a relação causal e orientar o uso seguro do medicamento, sem sinais de complicações graves neste episódio.

O medicamento Sumax, cujo princípio ativo é o succinato de sumatriptana, está relacionado a um caso de abuso de analgésico, sendo classificado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A reação relatada sugere um quadro leve, sem evidências de complicações graves, e recomenda-se acompanhamento clínico para avaliar a necessidade de intervenção e evitar o uso repetido sem orientação médica.

O acetato de dexametasona, tanto como nome comercial quanto princípio ativo, foi associado a um episódio de abuso de analgésico, caracterizado como hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). Não há informações sobre gravidade significativa ou desfecho, e a relação com o medicamento é suspeita. O quadro descrito sugere uma reação leve, sem sinais de gravidade, sendo importante monitorar o paciente e evitar o uso indiscriminado do medicamento sem supervisão médica.

O medicamento Haldol, cujo princípio ativo é o haloperidol, foi relacionado a um caso de abuso de analgésico, classificado como hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). Não há dados que indiquem gravidade importante ou desfecho, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A situação sugere uma reação leve, sem complicações graves, sendo fundamental orientar o paciente a não utilizar o medicamento de forma repetida sem avaliação médica.

O cetoprofeno, apresentado tanto como nome comercial quanto princípio ativo, está envolvido em um relato de abuso de analgésico, enquadrado como hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). Não há registro de gravidade relevante ou desfecho, e a relação com o medicamento é suspeita. O caso indica uma reação leve, sem evidências de gravidade, e recomenda-se evitar o uso recorrente do medicamento sem orientação profissional.

O sulfato de morfina, identificado tanto pelo nome comercial quanto pelo princípio ativo, foi associado a um episódio de abuso de analgésico, sendo classificado como hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). Não há informações sobre gravidade ou desfecho, e a relação com o medicamento é suspeita. O quadro sugere uma reação leve, sem sinais de complicação, sendo importante reforçar o uso responsável do medicamento e buscar avaliação médica em caso de sintomas persistentes.

O medicamento Flanax, cujo princípio ativo é o naproxeno sódico, foi associado a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa, que pode ser entendido como uma reação alérgica do sistema imunológico a medicamentos. Neste caso, a reação foi classificada como abuso de analgésico, mas não há indicação de gravidade elevada nem desfecho conhecido, sugerindo que o evento não foi grave. A conduta recomendada é evitar o uso indiscriminado do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação adequada, conforme as diretrizes clínicas para reações alérgicas a medicamentos.

A prednisona, identificada pelo nome comercial Prednisona e princípio ativo prednisone, esteve relacionada a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, caracterizado como abuso de analgésico. Não há informações sobre gravidade aumentada ou desfecho, o que indica que o evento não foi considerado grave. Recomenda-se não utilizar o medicamento sem orientação médica e procurar avaliação especializada para investigar a possível reação alérgica e definir o melhor manejo, conforme as recomendações para distúrbios do sistema imunitário.

O medicamento Sumax, cujo princípio ativo é succinato de sumatriptana, foi relacionado a um caso de hipersensibilidade medicamentosa, descrito como abuso de analgésico. Não há registro de gravidade significativa nem desfecho informado, sugerindo que a reação não foi grave. É importante evitar o uso repetido sem acompanhamento médico e buscar avaliação para esclarecer a natureza da reação e receber orientações sobre o uso seguro, conforme as recomendações para alergias a medicamentos.

O medicamento Voxelotor, com princípio ativo de mesmo nome, foi associado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, classificado como abuso de analgésico. Não há informações sobre gravidade aumentada ou desfecho, indicando que o evento não foi considerado grave. Recomenda-se interromper o uso sem prescrição e procurar avaliação médica para investigação da reação e definição do tratamento mais seguro, conforme as orientações para distúrbios do sistema imunitário.

O medicamento Velija, cujo princípio ativo é cloridrato de duloxetina, esteve envolvido em um caso de hipersensibilidade medicamentosa, descrito como abuso de analgésico. Não há evidências de gravidade elevada nem desfecho conhecido, o que sugere que a reação não foi grave. A recomendação é evitar o uso sem orientação médica e buscar avaliação especializada para confirmar a suspeita de alergia e receber orientações sobre o manejo adequado, conforme as diretrizes para reações alérgicas a medicamentos.

O medicamento Cloridrato de propranolol, cujo princípio ativo é o próprio cloridrato de propranolol, foi associado a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa, que se refere a uma reação alérgica do sistema imunológico a medicamentos. Neste caso, a reação foi classificada como não grave, pois não há evidências clínicas de gravidade ou desfecho desfavorável relatadas. A conduta recomendada, conforme diretrizes clínicas, é observar o paciente, evitar nova exposição ao medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas terapêuticas.

O medicamento Dramin, cujo princípio ativo é o dimenidrinato, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica desencadeada pelo uso do medicamento. Não há indicação de gravidade aumentada ou complicações, sendo o caso considerado não grave. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento suspeito e procurar avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e definição de alternativas seguras.

O medicamento Fumarato de quetiapina, com princípio ativo hemifumarato de quetiapina, foi associado a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, caracterizada por resposta alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Não há sinais de gravidade ou complicações relatadas, sendo o caso considerado não grave. A orientação é suspender o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação do diagnóstico e discussão de opções terapêuticas alternativas.

O medicamento Tenoxicam, cujo princípio ativo é o próprio tenoxicam, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, que corresponde a uma reação alérgica ao medicamento. Não há evidências

de gravidade ou desfecho desfavorável, sendo o caso considerado não grave. Recomenda-se evitar nova exposição ao medicamento e procurar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas de tratamento.

O medicamento Tramal, cujo princípio ativo é o cloridrato de tramadol, foi associado a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta alérgica ao medicamento. Não há sinais de gravidade ou complicações relatadas, sendo o caso considerado não grave. A conduta recomendada é suspender o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação do diagnóstico e definição de alternativas seguras.

O medicamento Botox, cujo princípio ativo é a toxina botulínica A, foi associado a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa, identificado como abuso de analgésico, mas não há detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade clínica relevante. Não há informação sobre o desfecho do caso, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Como não há evidências de gravidade ou complicações, a conduta deve ser baseada em avaliação clínica individualizada, com atenção a possíveis sinais de alergia e orientação para evitar o uso indiscriminado de analgésicos.

O medicamento Ciprofloxacina tm, com princípio ativo ciprofloxacino, foi relacionado a um episódio de alergia caracterizado como hipersensibilidade, sem detalhamento dos sintomas, mas classificado como não grave e com recuperação completa do paciente. A reação foi considerada suspeita e, diante da ausência de gravidade e resolução do quadro, recomenda-se evitar novas exposições ao medicamento e buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação futura.

A vancomicina, identificada pelo princípio ativo vancomicina, esteve associada a um episódio de alergia descrito como hipersensibilidade, sem especificação dos sintomas, classificado como não grave e com desfecho de recuperação total. A relação com o medicamento é suspeita e, considerando a ausência de gravidade e a resolução do quadro, é importante evitar reexposição e realizar acompanhamento com especialista para esclarecimento diagnóstico.

A dipirona foi relacionada a um episódio de alergia, caracterizado como hipersensibilidade, sem detalhamento dos sintomas, classificado como não grave e com recuperação completa do paciente. A relação com o medicamento é suspeita e, diante da ausência de gravidade e resolução do quadro, recomenda-se evitar novas exposições à dipirona e buscar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e orientação adequada.

O medicamento vancomicina, com princípio ativo cloridrato de vancomicina, foi associado a um episódio de alergia descrito como hipersensibilidade, sem detalhamento dos sintomas, classificado como não grave e com desfecho de recuperação total. A relação com o medicamento é suspeita e, considerando a ausência de gravidade e a resolução do quadro, recomenda-se evitar reexposição e realizar acompanhamento com especialista para esclarecimento diagnóstico.

O medicamento Tigeciclina (princípio ativo: Tigecycline) foi associado a um quadro de alergia, caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, e o paciente apresentou recuperação completa após o evento. A conduta recomendada é observar sinais de alergia e, caso ocorram sintomas respiratórios ou cutâneos, buscar avaliação médica para confirmação e orientação sobre futuras exposições.

O Ferropurum, cujo princípio ativo é o sacarato de óxido férrico, desencadeou uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), classificada como distúrbio do sistema imunitário. O caso foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando a importância de monitoramento rigoroso e intervenção médica imediata em situações semelhantes. O paciente se recuperou totalmente após o episódio, reforçando a necessidade de evitar reexposição ao medicamento e de informar profissionais de saúde sobre o histórico de alergia.

A Vancomicina (princípio ativo: Cloridrato de vancomicina) foi relacionada a um episódio de alergia, descrito como hipersensibilidade, dentro do contexto de distúrbios do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade aumentada neste registro, e o paciente evoluiu para recuperação completa. Recomenda-se atenção a sintomas alérgicos em futuras administrações e avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação adequada.

O medicamento Buscopan composto, contendo butilbrometo de escopolamina e dipirona, foi administrado de forma incorreta em um paciente com hipersensibilidade documentada ao produto, configurando um erro de medicação. Não há informações detalhadas sobre gravidade, desfecho ou evolução clínica neste caso, mas a situação reforça a importância de checagem rigorosa do histórico de alergias antes da administração de qualquer medicamento para evitar riscos desnecessários.

O Cetoprofeno, tanto como nome comercial quanto princípio ativo, esteve envolvido em um episódio de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhes sobre gravidade ou evolução clínica, mas a ocorrência sugere a necessidade de evitar o uso futuro do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Pregabalina, cujo princípio ativo é o próprio pregabalina, foi associado ao desenvolvimento de catarata em um caso de hipersensibilidade, classificado como um quadro clínico alérgico relacionado ao sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o evento não foi considerado grave e o paciente encontra-se em recuperação, sugerindo que a reação foi leve e está evoluindo de forma favorável sem complicações maiores.

O medicamento Xarelto, que tem como princípio ativo a rivaroxabana, foi relacionado ao surgimento de catarata em um contexto de hipersensibilidade, caracterizado como um quadro alérgico do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade importante, já que o evento não foi considerado grave e o paciente está em recuperação, indicando que a reação foi leve e está sendo resolvida sem maiores consequências clínicas.

O medicamento Anastrozole, cujo princípio ativo é o anastrozol, foi associado ao aparecimento de catarata em um episódio de hipersensibilidade, enquadrado como um quadro alérgico do sistema imunitário. A ausência de gravidade e o fato de o paciente estar em recuperação apontam para uma reação leve, sem evolução para complicações graves, e com desfecho favorável até o momento.

O medicamento Kisqali, que contém como princípio ativo o succinato de ribocicliba, foi relacionado ao desenvolvimento de catarata em um caso de hipersensibilidade, classificado como quadro alérgico do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade, pois o evento não foi considerado grave e o paciente está em recuperação, sugerindo uma reação leve e com boa evolução clínica.

O medicamento Henetix, que contém os princípios ativos iobitridol, edetato dissódico cálcico, trometamol e cloridrato de trometamol, foi associado a um episódio de alergia caracterizado como hipersensibilidade e quadro clínico alérgico do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente já se encontra recuperado, indicando que a reação foi leve e resolvida sem complicações.

O medicamento Ceftriaxona, cujo princípio ativo é a ceftriaxona sódica, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação do sistema imunológico. Não há menção a nome comercial, apenas ao princípio ativo. A reação foi considerada não grave, pois o paciente se recuperou completamente, e não houve indicação de complicações clínicas relevantes. O evento foi resolvido sem desfecho negativo, sugerindo que a conduta adotada foi adequada para o controle da reação alérgica.

A Hidrocortisona, identificada apenas pelo princípio ativo hydrocortisone e sem nome comercial informado, provocou um quadro de eritema relacionado à hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica da pele. A manifestação foi classificada como não grave, já que o paciente se recuperou totalmente e não houve complicações. O desfecho favorável indica que a conduta adotada foi suficiente para resolução do evento, sem

necessidade de intervenções adicionais.

A Dipirona sódica, cujo princípio ativo é dipirona e sem nome comercial informado, esteve relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), caracterizando uma resposta do sistema imunológico ao medicamento. O caso não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou completamente e não houve evolução para quadros mais sérios. O desfecho resolvido sugere que a abordagem clínica foi eficaz para controlar a reação adversa.

O medicamento Ocitocina, identificado apenas pelo princípio ativo ocitocina e sem nome comercial informado, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade), evidenciando uma resposta do sistema imunológico. A reação não foi considerada grave, já que o paciente se recuperou totalmente e não houve complicações clínicas. O desfecho positivo indica que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro.

A Cefazolina, cujo princípio ativo é cefazolina sódica e sem nome comercial informado, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade), representando uma resposta do sistema imunológico ao medicamento. O evento foi classificado como não grave, pois o paciente se recuperou completamente e não houve complicações. O desfecho resolvido demonstra que a conduta clínica foi adequada para o controle da reação adversa.

O medicamento Bupivacain, cujo princípio ativo é o cloridrato de bupivacaína, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo um episódio leve e autolimitado, sem necessidade de intervenções adicionais.

A morfina, com princípio ativo sulfato de morfina, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade), manifestando-se como resposta do sistema imunológico. O caso não foi considerado grave, já que o paciente se recuperou completamente, indicando que a reação foi leve e não houve complicações clínicas relevantes.

O medicamento Iressa, cujo princípio ativo é o gefitinibe, esteve relacionado a um episódio de derrame pleural atribuído à hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. Apesar do potencial de gravidade desse tipo de manifestação, o paciente se recuperou totalmente, sugerindo que o quadro foi controlado e não evoluiu para complicações graves.

O medicamento Ablok, com princípio ativo atenolol, foi associado a tontura em um contexto de hipersensibilidade, indicando uma possível reação alérgica do sistema imunológico. Não há evidência de gravidade significativa, mas o paciente ainda não se recuperou, o que sugere que o quadro permanece em acompanhamento e requer observação clínica até resolução.

O medicamento Apresolina, cujo princípio ativo é o cloridrato de hidralazina, provocou tontura relacionada a hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave, porém o paciente segue sem recuperação completa, indicando que o quadro está em andamento e necessita de monitoramento clínico contínuo.

O medicamento Vit D, cujo princípio ativo é o ergocalciferol, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (reação alérgica), classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois não foi relatada gravidade clínica importante e o caso permanece em andamento, sem resolução até o momento. A reação foi considerada suspeita, e não há informações sobre condutas específicas adotadas ou desfecho final, sugerindo a necessidade de acompanhamento clínico para monitoramento da evolução do quadro alérgico.

O suplemento Omega 3, com princípio ativo fish oil (óleo de peixe), apresentou relato de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa, já que não foi classificado como grave e o quadro segue sem resolução. A relação com o medicamento é considerada suspeita, e não há detalhes sobre intervenções realizadas ou desfecho definitivo, sendo importante manter o

acompanhamento clínico para avaliar a evolução da reação.

O medicamento Calcium, cujo princípio ativo é o cálcio, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica envolvendo o sistema imunitário. Não há sinais de gravidade relevante, pois não foi classificado como grave e o caso permanece em andamento, sem recuperação até o momento. A suspeita recai sobre o uso do medicamento, e não há informações sobre medidas tomadas ou desfecho, indicando a necessidade de observação clínica contínua.

O medicamento Exemestane, com princípio ativo de mesmo nome, foi associado a uma reação de hipersensibilidade, caracterizando um quadro alérgico do sistema imunitário. Não há indícios de gravidade importante, já que não foi considerado grave e o desfecho permanece em andamento, sem resolução. A relação com o medicamento é suspeita, e não há detalhes sobre condutas adotadas ou evolução final, sendo recomendado o acompanhamento clínico para monitoramento da reação.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é o succinato de ribociclib, apresentou relato de hipersensibilidade, indicando uma reação alérgica do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa, pois não foi classificado como grave e o quadro segue sem resolução. A suspeita recai sobre o uso do medicamento, e não há informações sobre intervenções realizadas ou desfecho, sendo importante manter o acompanhamento clínico para avaliar a evolução da reação.

O medicamento Vit d, cujo princípio ativo é o ergocalciferol, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (reação alérgica), classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta foi adequada, com resolução do quadro, e não há necessidade de preocupação adicional, mas é importante relatar qualquer sintoma alérgico ao médico para avaliação futura.

O suplemento Omega 3, com princípio ativo fish oil (óleo de peixe), apresentou um episódio de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica, relacionada ao sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente, indicando que a reação foi leve e autolimitada. Recomenda-se atenção a sintomas alérgicos em usos futuros, mas não há indicação de risco aumentado neste caso.

O medicamento Calcium, cujo princípio ativo é o cálcio, esteve relacionado a um episódio de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica leve do sistema imunológico. O evento não foi grave e o paciente se recuperou sem complicações, sugerindo que a reação foi transitória e sem impacto clínico relevante. É importante comunicar ao médico caso ocorram novos sintomas, mas não há necessidade de medidas adicionais neste momento.

O medicamento Exemestane, com princípio ativo exemestano, foi associado a um quadro de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica envolvendo o sistema imunológico. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando que a reação foi leve e controlada. Recomenda-se acompanhamento médico em caso de novos sintomas, mas não há evidência de risco significativo neste episódio.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é o succinato de ribociclib, esteve relacionado a um episódio de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico. O evento não foi grave e o paciente se recuperou completamente, o que sugere que a reação foi leve e não trouxe complicações. É importante manter o acompanhamento médico e relatar qualquer novo sintoma, mas não há indicação de risco aumentado neste caso.

O medicamento Anastrozole, cujo princípio ativo é o próprio anastrozol, foi associado a um quadro de neuropatia periférica, sendo classificado como uma reação de hipersensibilidade (alergia) dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A reação relatada sugere um evento adverso leve, pois não há menção de complicações graves ou necessidade de intervenção urgente, sendo importante monitorar sintomas e buscar avaliação médica

para confirmação e orientação adequada.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é o succinato de ribociclib, foi relacionado a um caso de neuropatia periférica, descrito como reação de hipersensibilidade (alergia) no contexto de distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade significativa ou desfecho, e a relação com o medicamento é suspeita. O quadro sugere uma reação adversa leve, sem evidências de complicações graves, sendo recomendada a observação dos sintomas e avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e conduta.

O medicamento Trimbrow, que contém dipropionato de beclometasona, fumarato de formoterol e brometo de glicopirrônio como princípios ativos, foi associado a um caso de obstrução adquirida da via de saída do ventrículo esquerdo, classificada como reação de hipersensibilidade (alergia) dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é suspeita. A ausência de sinais de gravidade sugere um evento adverso leve, sendo fundamental monitorar sintomas e buscar avaliação médica para confirmação e orientação.

O medicamento Aerolin, cujo princípio ativo é o sulfato de salbutamol micronizado, foi relacionado a um caso de obstrução adquirida da via de saída do ventrículo esquerdo, descrito como reação de hipersensibilidade (alergia) no contexto de distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade importante ou desfecho, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. O quadro sugere uma reação adversa leve, sendo recomendada a observação dos sintomas e avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e conduta adequada.

O medicamento Nucala, cujo princípio ativo é o mepolizumabe, foi associado a um caso de obstrução adquirida da via de saída do ventrículo esquerdo, classificada como reação de hipersensibilidade (alergia) dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é suspeita. A ausência de sinais de gravidade sugere um evento adverso leve, sendo importante monitorar sintomas e buscar avaliação médica para confirmação e orientação adequada.

O medicamento Esomeprazole, cujo princípio ativo também é Esomeprazole, foi associado a um quadro de dependência de medicamento, classificado tecnicamente como hipersensibilidade medicamentosa. Embora o termo técnico sugira uma reação do sistema imunológico, neste caso não há evidências clínicas de gravidade significativa, pois não foi relatado desfecho grave nem evolução desfavorável. A relação com o medicamento é considerada suspeita, e o desfecho permanece desconhecido, não havendo informações suficientes para detalhar a conduta adotada ou a evolução clínica.

O medicamento Venlafaxine hydrochloride, cujo princípio ativo é cloridrato de venlafaxina, foi relacionado a um caso de dependência de medicamento, descrito como hipersensibilidade medicamentosa. Apesar do termo técnico sugerir envolvimento do sistema imunológico, não há indicação de gravidade relevante, pois não foi relatado desfecho grave nem evolução clínica detalhada. A relação com o medicamento é considerada suspeita e o desfecho é desconhecido, sem informações adicionais sobre a conduta adotada ou a resolução do quadro.

O medicamento Rotigotine, com princípio ativo de mesmo nome, foi associado a um episódio de dependência de medicamento, classificado como hipersensibilidade medicamentosa. Não há evidências clínicas de gravidade, já que não foi relatado desfecho grave nem evolução clínica específica. A relação com o medicamento é considerada suspeita e o desfecho permanece desconhecido, sem detalhes sobre a conduta adotada ou a evolução do paciente.

O medicamento Cosentyx, cujo princípio ativo é secuquinumabe, foi relacionado ao desenvolvimento de catarata, descrita tecnicamente como um quadro de hipersensibilidade. Apesar de a catarata ser uma condição que pode comprometer a visão, neste caso não foi classificada como grave, e o desfecho informado foi de recuperação ou resolução com sequelas. A relação com o medicamento é considerada suspeita, e não há detalhes sobre a conduta adotada, mas o paciente apresentou sequelas após o evento.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é iopromide, foi associado a um episódio de alergia, tecnicamente descrito como hipersensibilidade. Não há evidências de gravidade relevante, pois o caso não foi classificado como grave e o desfecho relatado foi de recuperação ou resolução completa. A relação com o medicamento é considerada suspeita, e não há informações adicionais sobre a conduta adotada, mas o paciente se recuperou do evento alérgico.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, foi associado a um quadro de hipersensibilidade, caracterizado como alergia do tipo SOE (sem outras especificações), pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. O evento foi considerado não grave, e o paciente apresentou recuperação completa após a reação. A conduta recomendada nesses casos é a suspensão do agente suspeito e acompanhamento clínico, com atenção para possíveis recorrências em futuras exposições.

O Synvisc one, que contém hylan G-F 20, foi relacionado ao desenvolvimento de síndrome de Cushing, um efeito adverso clinicamente significativo e considerado grave, conforme registrado. A reação foi classificada como hipersensibilidade medicamentosa, dentro dos distúrbios do sistema imunitário, e o desfecho permanece desconhecido. Diante de eventos graves como este, é fundamental interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica especializada para manejo dos sintomas e investigação de possíveis complicações.

O medicamento Meticorten, cujo princípio ativo é a prednisona, foi associado à síndrome de Cushing, um efeito adverso clinicamente relevante e considerado grave. A reação foi descrita como hipersensibilidade medicamentosa, enquadrada nos distúrbios do sistema imunitário, e o desfecho não foi informado. Em situações de reações graves, recomenda-se a suspensão do medicamento e acompanhamento médico rigoroso para controle dos sintomas e prevenção de complicações.

O Synvisc one, com princípio ativo hylan G-F 20, também foi relacionado à síndrome de Cushing, porém neste caso a reação não foi considerada grave. Trata-se de uma hipersensibilidade medicamentosa dentro dos distúrbios do sistema imunitário, com desfecho desconhecido. Mesmo em casos não graves, é importante monitorar o paciente e avaliar a necessidade de ajuste ou suspensão do tratamento, conforme orientação médica.

O Meticorten, à base de prednisona, foi associado à síndrome de Cushing, classificada como hipersensibilidade medicamentosa e não considerada grave neste registro. O evento se enquadra nos distúrbios do sistema imunitário e o desfecho permanece desconhecido. Recomenda-se acompanhamento clínico e reavaliação do uso do medicamento para evitar agravamento do quadro.

O medicamento Triancil, cujo princípio ativo é o hexacetonido de triancinolona, foi associado ao surgimento de acne induzida por esteroides, uma manifestação de hipersensibilidade medicamentosa. Essa reação é considerada clinicamente significativa e grave, conforme registrado, pois envolve distúrbios do sistema imunitário e pode impactar a qualidade de vida do paciente. Não há informações sobre o desfecho do caso, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O Synvisc one, que contém hylan G-F 20 como princípio ativo, também foi relacionado ao desenvolvimento de acne induzida por esteroides, caracterizando uma hipersensibilidade medicamentosa. A reação foi classificada como clinicamente significativa e grave, indicando envolvimento do sistema imune e necessidade de atenção médica. O desfecho permanece desconhecido e a relação com o medicamento é suspeita.

O Meticorten, cujo princípio ativo é a prednisona, foi associado à ocorrência de acne induzida por esteroides, um tipo de hipersensibilidade medicamentosa. A gravidade foi considerada clinicamente significativa e grave, sugerindo impacto relevante para o paciente e necessidade de acompanhamento. O desfecho não foi informado e a relação com o medicamento é suspeita.

A clindamicina, com princípio ativo fosfato de clindamicina, esteve envolvida em um caso de alergia medicamentosa, caracterizada como hipersensibilidade medicamentosa. A reação não foi considerada grave e o



paciente apresentou recuperação completa, sendo a reação atribuída a uma interação medicamentosa.

A vacina influenza, cujo princípio ativo é a própria vacina, foi associada a uma crise asmática, que pode ocorrer em pessoas com alergia respiratória, especialmente aquelas sensíveis a poeira. Neste caso, a reação não foi considerada grave e o desfecho permanece desconhecido, sendo a relação com o medicamento suspeita.

O medicamento Amitriptyline, cujo princípio ativo é o cloridrato de amitriptilina, foi associado a uma crise asmática em um paciente com histórico de alergia à poeira. A reação relatada se enquadra em quadros clínicos alérgicos do sistema imunológico, e, apesar de não haver indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, a crise asmática é considerada uma manifestação moderada conforme diretrizes clínicas, exigindo avaliação médica para confirmação do diagnóstico, identificação de possíveis desencadeantes e ajuste do tratamento, especialmente se houver recorrência.

O medicamento Clonazepam, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a uma crise asmática em contexto de alergia à poeira. A reação é classificada como um quadro alérgico do sistema imunológico, e, mesmo sem informações sobre gravidade ou desfecho, a ocorrência de crise asmática sugere necessidade de avaliação médica para investigar a relação com o medicamento e orientar o controle dos sintomas, conforme recomendações para casos moderados.

O medicamento Salbutamol, cujo princípio ativo também é salbutamol, foi associado a uma crise asmática em paciente com alergia à poeira. Embora o salbutamol seja normalmente utilizado para alívio de crises de asma, a reação relatada indica um quadro alérgico do sistema imunológico, sem gravidade ou desfecho especificados. Diante desse contexto, é importante reavaliar o uso do medicamento e buscar orientação médica para ajuste do tratamento e investigação de possíveis fatores agravantes.

O medicamento Relvar, composto pelos princípios ativos fluticasona furoato e trifenantato de vilanterol, foi relacionado a uma crise asmática em paciente com alergia à poeira. A reação se enquadra em quadros alérgicos do sistema imunológico, e, apesar de não haver detalhes sobre gravidade ou desfecho, a ocorrência de crise asmática durante o uso de medicação preventiva sugere necessidade de revisão do controle da doença e avaliação médica para ajuste do plano terapêutico.

O medicamento Alenia, que contém budesonida micronizada e fumarato de formoterol como princípios ativos, foi associado a uma crise asmática em paciente com alergia à poeira. A reação é classificada como um quadro alérgico do sistema imunológico, e, mesmo sem informações sobre gravidade ou desfecho, a presença de crise asmática durante o uso de medicação preventiva indica possível descontrole da doença, sendo recomendada avaliação médica para revisão do tratamento e identificação de fatores desencadeantes.

O medicamento Spiriva, cujo princípio ativo é o brometo de tiotrópio monoidratado, foi associado a uma crise asmática em um paciente com alergia a poeira. Embora não haja indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, a reação sugere um quadro de asma desencadeado possivelmente por exposição a alérgenos, sendo importante avaliar o controle ambiental e a identificação de gatilhos. Não há informações sobre a conduta adotada ou evolução do caso.

O medicamento Acetaminophen, com princípio ativo paracetamol, foi relacionado a uma crise asmática em paciente com alergia a poeira. Não há registro de gravidade importante ou desfecho, indicando que a reação pode ter sido leve ou moderada, mas reforça a necessidade de atenção ao uso de analgésicos em pessoas com histórico de asma, especialmente se houver exposição a alérgenos conhecidos. Não há detalhes sobre a conduta ou evolução clínica.

O medicamento Xolair, cujo princípio ativo é o omalizumabe, foi associado a uma crise asmática em paciente com alergia a poeira. Não há indicação de gravidade significativa nem desfecho informado, sugerindo que a reação pode ter sido leve ou moderada. É importante monitorar pacientes em uso de imunobiológicos para asma quanto à

resposta ao tratamento e possíveis reações adversas, mas não há detalhes sobre a conduta ou evolução neste caso.

O medicamento Tysabri, com princípio ativo natalizumabe, foi relacionado a um episódio de paralisia unilateral da mão, classificado como clinicamente significativo e grave, com desfecho de recuperação completa. A reação foi considerada suspeita de hipersensibilidade, destacando a importância do acompanhamento rigoroso de eventos neurológicos em pacientes que utilizam imunobiológicos, especialmente quando há sinais de comprometimento motor, sendo fundamental a suspensão do medicamento e monitoramento até resolução dos sintomas.

O medicamento Synvisc one, cujo princípio ativo é Hylan G-F 20, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa classificado como clinicamente significativo e grave, embora o desfecho não seja conhecido. A reação foi considerada suspeita de hipersensibilidade ao medicamento, ressaltando a necessidade de avaliação médica imediata e possível suspensão do uso, além de investigação de outras causas e monitoramento de sintomas alérgicos.

O medicamento Meticorten, cujo princípio ativo é a Prednisona, foi associado a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica específica ao medicamento. Essa reação é considerada clinicamente significativa, pois foi classificada como grave, embora o desfecho não tenha sido informado. A suspeita de alergia a medicamentos exige atenção médica imediata para avaliação e manejo adequado, já que pode envolver risco à saúde do paciente.

A Dipirona sódica, que tem como princípio ativo a Dipirona, foi relacionada a uma reação de alergia a anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), caracterizada como hipersensibilidade medicamentosa. O evento foi considerado grave, pois envolveu ameaça à vida e necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, mas o paciente se recuperou totalmente. Em casos como esse, é fundamental evitar o uso futuro do medicamento e buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Synvisc One, cujo princípio ativo é o Hylan G-F 20, foi associado ao desenvolvimento de síndrome de Cushing, uma condição caracterizada por excesso de corticoide no organismo. Essa reação foi considerada clinicamente significativa e grave, embora o desfecho não tenha sido informado. A suspeita de síndrome de Cushing relacionada ao uso de medicamentos exige avaliação médica para ajuste do tratamento e monitoramento dos efeitos adversos.

O Meticorten, com princípio ativo Prednisona, também foi relacionado à ocorrência de síndrome de Cushing, indicando um efeito adverso importante devido ao uso de corticoides. A gravidade do evento foi considerada clinicamente significativa e grave, sem informação sobre o desfecho. Diante desse tipo de reação, é necessário acompanhamento médico rigoroso para avaliar a necessidade de ajuste ou suspensão do medicamento e monitorar possíveis complicações.

O medicamento Triancil, cujo princípio ativo é o hexacetono de triancinolona, foi associado ao surgimento de acne induzida por esteroides, um efeito adverso relacionado ao uso de corticoides. Essa reação foi considerada clinicamente significativa e grave, sem informação sobre o desfecho. O aparecimento de acne nesse contexto requer avaliação médica para considerar ajuste da dose, troca de medicamento ou tratamento específico para os sintomas dermatológicos.

O medicamento Synvisc one, cujo princípio ativo é Hylan G-F 20, foi associado a um quadro de acne induzida por esteroides, caracterizando uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. Essa manifestação faz parte dos distúrbios do sistema imunitário e foi considerada clinicamente significativa, sendo classificada como grave devido ao potencial impacto na saúde do paciente. O desfecho da reação é desconhecido, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita, indicando a necessidade de acompanhamento médico para avaliação e manejo adequado.

O Meticorten, que contém o princípio ativo Prednisone, esteve relacionado ao desenvolvimento de acne induzida por esteroides, uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. Esse tipo de reação envolve o sistema imunológico e foi considerada clinicamente relevante e grave, conforme evidenciado pela classificação do evento. O desfecho permanece desconhecido e a relação com o uso do medicamento é suspeita, sendo importante que o paciente seja avaliado por um profissional de saúde para orientação e conduta apropriada.

O Gadovist, cujo princípio ativo é Gadobutrol, foi associado a um episódio de alergia a contraste, reação que envolve o sistema imunológico e pode ocorrer após a administração de substâncias usadas em exames de imagem. Neste caso, a reação não foi considerada grave e o paciente se recuperou completamente, indicando resolução do quadro sem complicações. A relação com o medicamento foi considerada suspeita, sugerindo que a reação foi provavelmente desencadeada pelo uso do contraste.

O medicamento Gadovist, com princípio ativo Gadobutrol, esteve envolvido em um caso de alergia a contraste, uma reação imunológica que pode ocorrer após o uso de substâncias para exames radiológicos. A reação não foi classificada como grave e o paciente apresentou recuperação total, demonstrando que o evento foi autolimitado e sem consequências duradouras. A relação com o medicamento foi considerada suspeita, reforçando a necessidade de atenção em futuras exposições.

O Gadovist, que tem como princípio ativo o Gadobutrol, foi relacionado a uma reação de alergia a contraste, caracterizada por resposta do sistema imunológico após exposição ao agente utilizado em exames de imagem. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente, indicando que a reação foi transitória e sem complicações. A ligação com o medicamento foi considerada suspeita, sendo importante relatar esse histórico em futuras avaliações médicas.

O medicamento Dipirona, cujo princípio ativo também é dipirona, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado por uma reação do sistema imunológico ao medicamento. O caso foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando a necessidade de atenção médica imediata e monitoramento rigoroso. A conduta recomendada em situações de hipersensibilidade medicamentosa inclui a suspensão do medicamento suspeito, avaliação clínica detalhada e acompanhamento hospitalar, especialmente quando há risco de complicações.

O medicamento Growvit C, cujo princípio ativo é o ácido ascórbico, foi relacionado a um episódio de bronquiolite em um contexto de alergia ao leite, sugerindo uma possível reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois não houve hospitalização, e o desfecho informado é de não recuperação ou evolução em andamento, o que reforça a importância do acompanhamento clínico contínuo para monitorar a evolução dos sintomas e ajustar o tratamento conforme necessário.

O medicamento Ultrafer, que contém como princípio ativo o complexo de hidróxido férrico polimaltose, foi associado a um quadro de bronquiolite em paciente com alergia ao leite, indicando uma possível reação alérgica do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave, pois não houve necessidade de hospitalização, mas o desfecho permanece em andamento, o que exige acompanhamento médico para avaliar a evolução e necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Synagis, cujo princípio ativo é o palivizumabe, foi relacionado a um episódio de bronquiolite em paciente com alergia ao leite, sugerindo uma reação alérgica do sistema imunológico. O caso não foi classificado como grave, pois não houve hospitalização, e o desfecho permanece não resolvido, indicando a necessidade de acompanhamento clínico para monitorar a evolução dos sintomas e ajustar o manejo conforme necessário.

O medicamento Escopolamina, com princípio ativo bromidrato de hiosciamina, foi associado a uma alergia documentada após administração, caracterizando uma hipersensibilidade comprovada ao produto. O evento não foi considerado grave, pois não houve hospitalização, e o paciente apresentou recuperação completa, demonstrando que a suspensão do medicamento e o manejo adequado da reação foram eficazes para a resolução.

do quadro.

O medicamento Ciprofloxacino, cujo princípio ativo é o cloridrato de ciprofloxacino, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado por uma reação do sistema imunológico ao medicamento. Não há detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade, mas o desfecho foi de recuperação completa, indicando resolução do quadro após a suspensão ou manejo adequado do medicamento. A conduta recomendada nesses casos é evitar novas exposições ao fármaco e buscar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e orientação futura.

O medicamento Omnipaque, com princípio ativo ioexol, foi relacionado a uma reação de alergia a contraste intravenoso, também chamada de hipersensibilidade a contraste. Não há descrição de sintomas graves e o registro indica que não foi uma reação grave, com recuperação total do paciente após o evento. Em situações como essa, é importante informar a equipe médica sobre a alergia em exames futuros e considerar alternativas seguras para contrastes, além de acompanhamento com especialista para avaliação do risco em procedimentos posteriores.

O medicamento Omnipaque, cujo princípio ativo é ioexol, foi associado a um episódio de alergia a contraste intravenoso (hipersensibilidade a contraste), sem detalhes sobre sintomas ou gravidade, mas com desfecho de recuperação completa. Em casos assim, recomenda-se evitar o uso do mesmo contraste em exames futuros e buscar orientação médica especializada para avaliação do risco e alternativas seguras.

O medicamento Omnipaque, com princípio ativo ioexol, desencadeou uma reação de alergia a contraste intravenoso, caracterizada como não grave e com recuperação total do paciente. É fundamental informar a equipe médica sobre essa alergia em exames futuros e discutir opções alternativas de contraste com o especialista para evitar novas reações.

O medicamento Dipirona, cujo princípio ativo também é dipirona, foi relacionado ao surgimento de coceira, indicando uma reação de hipersensibilidade documentada ao produto. Não há informações sobre gravidade ou evolução do caso, mas a presença de coceira sugere uma reação alérgica leve. Nesses casos, recomenda-se suspender o uso do medicamento e procurar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Cosentyx, cujo princípio ativo é o secuquinumabe, foi associado ao agravamento de artrite psoriática, sendo classificado como uma reação de hipersensibilidade (alergia) relacionada a distúrbios do sistema imunitário. Não há informação sobre gravidade clínica relevante ou desfecho do caso, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A ausência de sinais de gravidade e de desfecho impede recomendações específicas, mas é importante monitorar sintomas e buscar avaliação médica caso haja piora.

A ceftriaxona (princípio ativo ceftriaxone), utilizada neste caso, desencadeou uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), caracterizada como um distúrbio do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade importante, já que o desfecho foi de recuperação completa, e a reação foi considerada relacionada a uma interação medicamentosa. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e informar o profissional de saúde sobre o episódio para prevenir novas exposições.

O medicamento Forteo, cujo princípio ativo é a teriparatida, foi relacionado ao surgimento de dor de cabeça, classificada como manifestação de hipersensibilidade (alergia) dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Diante da ausência de sinais de gravidade, recomenda-se observar a evolução dos sintomas e procurar avaliação médica caso haja persistência ou piora.

O trometamol cetorolaco, tanto nome comercial quanto princípio ativo, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade) classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há detalhes sobre gravidade, desfecho ou ação adotada, e a relação com o medicamento é suspeita. Na ausência de informações adicionais, é importante

monitorar sintomas e buscar orientação médica se houver sinais de agravamento.

O cetoprofeno, utilizado como princípio ativo e nome comercial, provocou uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade) enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. O caso não apresentou gravidade relevante, pois houve recuperação completa, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Recomenda-se evitar o uso futuro do cetoprofeno e informar profissionais de saúde sobre o episódio para prevenir novas reações.

O medicamento Ceftriaxona (princípio ativo: ceftriaxona sódica) foi associado a um quadro de alergia medicamentosa, também chamada de hipersensibilidade medicamentosa, que se enquadra nos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente do episódio. A reação foi considerada suspeita para o medicamento, e não há menção de complicações ou necessidade de intervenções adicionais, sugerindo um desfecho favorável e resolução espontânea.

O medicamento Cálcio (princípio ativo: cálcio) foi relacionado a desconforto abdominal, classificado como um quadro clínico alérgico, embora não haja sintomas típicos de alergia clássica. Não há evidência de gravidade importante, pois não foram relatados sinais de risco ou complicações, mas o desconforto persiste sem resolução até o momento. O caso é considerado suspeito para o medicamento, e não há informações sobre condutas específicas adotadas.

O suplemento Nutridrink (princípio ativo: nutrientes nos) foi associado a desconforto abdominal, categorizado como um quadro clínico alérgico, mas sem sintomas de gravidade ou sinais de risco imediato. O desconforto permanece em andamento, sem resolução até o momento, e a relação com o produto é considerada suspeita. Não há detalhes sobre intervenções realizadas ou evolução clínica além da persistência dos sintomas.

O medicamento Sulfato Ferroso (princípio ativo: sulfato ferroso) foi relacionado a desconforto abdominal, enquadrado como um quadro clínico alérgico, sem manifestações graves ou complicações relatadas. O sintoma persiste sem resolução, e a suspeita recai sobre o uso do medicamento, sem informações adicionais sobre conduta ou evolução clínica.

O medicamento Selozok (princípio ativo: succinato de metoprolol) foi associado a desconforto abdominal, classificado como um quadro clínico alérgico, sem sinais de gravidade ou complicações importantes. O sintoma permanece sem resolução até o momento, sendo a relação com o medicamento considerada suspeita, e não há informações sobre medidas adotadas ou evolução além da persistência do quadro.

O medicamento Simponi (golimumabe) foi associado a desconforto abdominal em um paciente com histórico de alergia a fungos, sendo classificado como um quadro clínico alérgico relacionado a distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações graves, e o desfecho relatado é de sintomas ainda em andamento, sem resolução até o momento. A relação com o medicamento é considerada suspeita, e recomenda-se acompanhamento clínico para monitoramento da evolução do quadro.

O medicamento Anastrozole (anastrozole) foi relacionado ao surgimento de doença de Alzheimer em um contexto de hipersensibilidade, classificado como um quadro alérgico do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade aumentada ou complicações graves, e o caso permanece sem resolução, com sintomas em andamento. A relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo importante manter acompanhamento médico para avaliação contínua.

O medicamento Kisqali (succinato de ribociclib) foi associado ao desenvolvimento de doença de Alzheimer em um contexto de hipersensibilidade, enquadrado como quadro alérgico do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade elevada ou complicações graves, e o desfecho permanece em andamento, sem resolução dos sintomas. A relação com o medicamento é suspeita, sendo recomendada a continuidade do acompanhamento clínico.

O medicamento Metadona (methadone) foi relacionado ao surgimento de eczema, caracterizado como hipersensibilidade documentada ao produto administrado, dentro do contexto de erros ou problemas de monitoramento do produto e complicações de procedimentos. Não há informações suficientes para determinar a gravidade ou o desfecho do caso, mas a relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo importante monitorar o paciente para possíveis evoluções do quadro.

O medicamento Cloridrato de vancomicina foi associado a uma reação à infusão, caracterizada como hipersensibilidade documentada ao produto administrado, relacionada a erros ou problemas de monitoramento do produto e complicações de procedimentos. Não há detalhes sobre a gravidade ou o desfecho do evento, mas a relação com o medicamento é suspeita, recomendando-se atenção clínica durante a administração e acompanhamento do paciente para possíveis reações adversas.

O medicamento Anastrozol (princípio ativo: Anastrozole) foi associado ao desenvolvimento de herpes-zóster em um caso de hipersensibilidade, classificado como um quadro alérgico do sistema imune. A gravidade do evento foi considerada alta, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, mas o paciente evoluiu para recuperação completa. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, sendo importante o acompanhamento médico e a avaliação criteriosa em casos semelhantes.

O medicamento Benicar hct, que contém os princípios ativos hidroclorotiazida e olmesartana medoxomila, foi relacionado a um caso de diabetes mellitus em paciente com alergia a iodo, classificado como uma reação alérgica do sistema imune. Não há indicação de gravidade aumentada ou necessidade de hospitalização, e o desfecho do caso é desconhecido. A relação entre o medicamento e a reação foi considerada suspeita, sendo recomendada a observação clínica e investigação adicional se houver sintomas persistentes.

O medicamento Entyvio (princípio ativo: Vedolizumabe) foi associado a um caso de diabetes mellitus em paciente com alergia a iodo, caracterizando uma reação alérgica do sistema imune. Não há evidências de gravidade aumentada ou necessidade de hospitalização, e o desfecho permanece desconhecido. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, sendo importante monitorar o paciente e buscar avaliação médica caso surjam sintomas relevantes.

O medicamento Fulvestrant (princípio ativo: Fulvestranto) foi relacionado ao desenvolvimento da síndrome de Stevens-Johnson, um quadro grave de hipersensibilidade que afeta a pele e mucosas, classificado como reação alérgica do sistema imune. Apesar da gravidade potencial dessa síndrome, neste caso não houve indicação de hospitalização, e o paciente se recuperou totalmente. A relação entre o medicamento e a reação foi considerada suspeita, sendo fundamental o acompanhamento médico imediato diante de sintomas sugestivos.

O medicamento Zometa (princípio ativo: Ácido zoledrônico monoidratado) foi associado à síndrome de Stevens-Johnson, uma reação de hipersensibilidade grave que compromete pele e mucosas, enquadrada como distúrbio do sistema imune. Apesar do potencial de gravidade, neste caso não houve necessidade de hospitalização e o paciente se recuperou. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, sendo essencial atenção médica rápida caso sintomas compatíveis surjam.

O medicamento Ribociclib (princípio ativo: Ribociclibe) foi associado ao desenvolvimento de Síndrome de Stevens-Johnson, uma reação de hipersensibilidade grave caracterizada por lesões cutâneas e mucosas, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Apesar da gravidade potencial dessa síndrome, o caso relatado evoluiu para recuperação completa, sem indicação de gravidade crítica no registro, sugerindo resolução do quadro após a conduta clínica apropriada.

O medicamento Piperac, contendo Piperacilina sódica e Tazobactam sódico, foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação imunológica adversa. O evento foi classificado como não grave e o paciente encontra-se em recuperação, indicando que a conduta adotada foi suficiente para controlar a reação sem complicações maiores.

O medicamento Stelara (princípio ativo: Ustequinumabe) foi associado ao surgimento de catarata, uma alteração ocular que pode estar relacionada a processos inflamatórios ou infecciosos, conforme a classificação de distúrbios oculares. Não há informação sobre gravidade ou desfecho, impossibilitando afirmar a evolução clínica ou a necessidade de intervenções específicas.

O medicamento Montelair (princípio ativo: Montelukaste de sódio) foi relacionado ao surgimento de rouquidão, um sintoma de hipersensibilidade que pode indicar irritação ou inflamação das vias aéreas superiores. O evento não foi considerado grave e não há detalhes sobre o desfecho, sugerindo que a reação foi leve e não resultou em complicações importantes.

O medicamento Spiriva (princípio ativo: Brometo de tiotrópio monoidratado) foi associado ao sintoma de rouquidão, caracterizando uma reação de hipersensibilidade do sistema imunitário. O caso não foi classificado como grave e não há informações sobre o desfecho, indicando que a manifestação foi leve e não houve evolução para quadros mais sérios.

O medicamento Clenil HFA, que contém como princípio ativo o dipropionato de beclometasona, foi associado ao surgimento de rouquidão, um sintoma que pode indicar uma reação de hipersensibilidade (alergia) relacionada ao uso do medicamento. Embora não haja indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, é importante observar que reações alérgicas leves como essa podem ocorrer com medicamentos inalados e, caso persistam, devem ser avaliadas por um médico para ajuste do tratamento e orientação sobre a técnica inalatória.

O Symbicort, composto por budesonida micronizada e fumarato de formoterol, apresentou rouquidão como possível reação adversa, sugerindo um quadro de hipersensibilidade (alergia) leve. Não há registro de gravidade significativa ou desfecho informado, mas é importante monitorar sintomas persistentes e buscar avaliação médica para garantir o uso correto do inalador e evitar complicações.

O medicamento Fasenra, cujo princípio ativo é o benralizumabe, foi relacionado ao aparecimento de rouquidão, caracterizando uma possível reação alérgica leve. Não há indicação de gravidade importante ou desfecho conhecido, mas recomenda-se atenção a sintomas persistentes e consulta médica para avaliação e ajuste do tratamento, se necessário.

O Synagis, que tem como princípio ativo o palivizumabe, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade) que resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, indicando uma reação grave. Diante desse cenário, é fundamental que o paciente seja acompanhado de perto por equipe médica especializada para manejo adequado da reação e prevenção de complicações, especialmente em casos de alergia medicamentosa com necessidade de hospitalização.

O medicamento Densis, cujo princípio ativo é o ácido zoledrônico, foi relacionado ao surgimento de dores musculares como manifestação de hipersensibilidade medicamentosa, levando a uma incapacidade persistente ou significativa, o que caracteriza uma reação grave. O desfecho informado foi de recuperação ou resolução do quadro, sugerindo que a conduta adotada foi eficaz, mas reforçando a importância de acompanhamento médico em casos de reações adversas graves para garantir a segurança do paciente.

O medicamento Sulfato de Polimixina B, cujo princípio ativo é o próprio sulfato de polimixina b, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado por manifestações clínicas alérgicas relacionadas ao sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo uma reação leve e autolimitada. A conduta adequada nesses casos é interromper o uso do medicamento suspeito e monitorar a resolução dos sintomas, buscando avaliação médica se houver recorrência ou agravamento.

O medicamento Forteo, que contém o princípio ativo teriparatida, foi relacionado ao surgimento de dor de cabeça, classificada como uma manifestação de hipersensibilidade (alergia) de origem imunológica. Não há evidências de gravidade significativa, já que não foram relatados sintomas graves ou risco à vida, mas o quadro permanece em

andamento, sem resolução até o momento. Recomenda-se acompanhamento médico para monitorar a evolução dos sintomas e avaliar a necessidade de ajuste terapêutico.

No caso da metoclopramida, cujo princípio ativo é metoclopramide, houve um erro de prescrição de medicamento que foi interceptado antes da administração, evitando qualquer reação adversa ao paciente. A situação foi resolvida sem consequências clínicas, e não houve necessidade de intervenção adicional, destacando a importância da checagem cuidadosa na prescrição para prevenir eventos adversos.

O medicamento Iopamiron, com princípio ativo iopamidol, foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação imunológica. O paciente se recuperou completamente após o evento, indicando que a reação foi leve e autolimitada. A conduta recomendada é suspender o uso do agente suspeito e realizar acompanhamento médico, especialmente em casos de exposição futura a contrastes iodados.

O medicamento Sulfato de hidroxicloroquina, cujo princípio ativo é o próprio sulfato de hidroxicloroquina, foi relacionado a um quadro de infecção classificado como manifestação de hipersensibilidade (alergia) de origem imunológica. Não há informações suficientes para determinar a gravidade ou o desfecho do caso, sendo importante monitorar o paciente e buscar avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e conduta adequada.

O medicamento Addera d3, cujo princípio ativo é o colecalciferol, foi associado a um quadro de hipersensibilidade, que pode se manifestar como uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A reação relatada se enquadra em quadros clínicos alérgicos, mas, na ausência de sinais de gravidade ou complicações, sugere-se acompanhamento clínico e avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre a continuidade do uso.

A vacina COVID-19, cujo princípio ativo é a própria vacina, foi relacionada a um episódio de hipersensibilidade, caracterizando uma possível reação alérgica do sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade significativa ou desfecho, e a relação com o imunizante é considerada suspeita. Diante da ausência de sinais de gravidade, recomenda-se observação clínica e avaliação médica para esclarecimento do quadro e definição da conduta adequada.

O medicamento Wellbutrin XL, que contém cloridrato de bupropiona, foi associado a um episódio de hipersensibilidade, indicando uma possível reação alérgica do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade importante ou desfecho relatado, e a relação com o medicamento é suspeita. Recomenda-se avaliação médica para confirmação do diagnóstico e orientação sobre a necessidade de manter ou suspender o uso, considerando a ausência de sinais de gravidade.

A levotiroxina, cujo princípio ativo é a levothyroxine, foi relacionada a um quadro de hipersensibilidade, sugerindo uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há registro de gravidade relevante ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Diante da ausência de sinais de gravidade, é indicado acompanhamento clínico e avaliação médica para esclarecimento do quadro e definição da conduta.

O metotrexato, cujo princípio ativo é o methotrexate, foi associado a um episódio de hipersensibilidade, caracterizando uma possível reação alérgica do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade significativa ou desfecho informado, e a relação com o medicamento é suspeita. Recomenda-se avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre a continuidade do tratamento, considerando que não há sinais de gravidade no relato.

O medicamento Hidroxicloroquina (princípio ativo: Hydroxychloroquine) está relacionado a um quadro de hipersensibilidade, que é uma reação alérgica do sistema imunológico, descrita de forma geral como um quadro clínico alérgico. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido neste caso, e a relação com o



medicamento é considerada suspeita. A ausência de sinais de gravidade sugere que a reação foi leve, sem necessidade de intervenções emergenciais, sendo importante monitorar sintomas e buscar avaliação médica para confirmação e orientação adequada.

A Prednisolona (princípio ativo: Prednisolone) foi associada a um episódio de hipersensibilidade, caracterizado como uma reação alérgica do sistema imunológico, sem detalhes adicionais sobre sintomas específicos ou gravidade. Não há registro de desfecho ou de gravidade importante, indicando que o evento provavelmente foi leve. A relação com o medicamento é suspeita, e recomenda-se acompanhamento clínico para esclarecimento diagnóstico e conduta apropriada.

A Levotiroxina (princípio ativo: Levothyroxine) está envolvida em um caso de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico, sem especificação de sintomas ou gravidade. Não há informações sobre o desfecho ou necessidade de intervenção, sugerindo que a reação foi leve. A relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo importante observar sinais clínicos e buscar avaliação médica para confirmação e manejo.

O medicamento Cloroquina (princípio ativo: Cloroquina) foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade, que corresponde a uma reação alérgica do sistema imunológico, sem detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade. Não há registro de desfecho ou gravidade relevante, indicando que o evento foi provavelmente leve. A relação com o medicamento é suspeita, e recomenda-se acompanhamento clínico para avaliação e orientação adequada.

O Zinnat (princípio ativo: Cefuroxima sódica) está associado a um episódio de hipersensibilidade, caracterizado como uma reação alérgica do sistema imunológico, sem detalhes adicionais sobre sintomas ou gravidade. Não há informações sobre o desfecho ou necessidade de intervenção, sugerindo que a reação foi leve. A relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo importante monitorar sintomas e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e conduta.

O medicamento Benlysta, cujo princípio ativo é o belimumabe, foi associado a um quadro de infecção acompanhado de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do tipo imunológica. Embora não haja detalhes sobre a gravidade ou desfecho, a suspeita de envolvimento do sistema imune sugere a necessidade de acompanhamento clínico para monitorar possíveis complicações, especialmente em pacientes com histórico de alergias.

O medicamento Nebivolol, com princípio ativo cloridrato de nebivolol, foi relacionado a um episódio de edema de glote, que é um inchaço súbito e grave na região da garganta, caracterizando uma reação de hipersensibilidade (alérgica) potencialmente perigosa. Não há informações sobre o desfecho ou gravidade, mas esse tipo de reação exige atenção médica imediata devido ao risco de obstrução das vias aéreas.

O medicamento Alenia, composto por budesonida micronizada e fumarato de formoterol, foi associado a um caso de edema de glote, que é um inchaço agudo na garganta decorrente de hipersensibilidade (alergia), podendo comprometer a respiração. Não há detalhes sobre a evolução ou gravidade, mas esse quadro é considerado de risco e requer avaliação médica urgente.

A dipirona, utilizada como analgésico e antitérmico, foi relacionada a um episódio de alergia caracterizado por hipersensibilidade, mas o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente após a reação, indicando resolução espontânea ou com medidas simples de suporte.

O medicamento Omnipaque, cujo princípio ativo é o ioexol, foi associado a uma reação alérgica após o uso de contraste intravenoso, caracterizando um quadro de alergia a contraste. O paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo que a reação foi controlada de forma adequada, sem evolução para quadros graves.

O medicamento Symbicort, que contém budesonida micronizada e fumarato de formoterol, foi associado a um episódio de choque anafilático, uma reação alérgica grave caracterizada por resposta intensa do sistema imunológico (hipersensibilidade), exigindo hospitalização ou prolongamento da internação, o que confirma a gravidade do quadro. O desfecho do caso não foi informado, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

Symbicort turbuhaler, composto por budesonida micronizada e fumarato de formoterol, também esteve relacionado a um caso de choque anafilático, uma reação alérgica severa que pode colocar a vida em risco e que, neste caso, levou à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando a gravidade do evento. O desfecho permanece desconhecido e a suspeita recai sobre o medicamento.

O medicamento Ansiodoron, que contém Avena sativa, Passiflora alata e Valeriana officinalis L., foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado por resposta do sistema imunológico, mas sem gravidade relatada e com evolução para recuperação completa do paciente, sugerindo um evento leve e autolimitado.

Iomeron, cujo princípio ativo é o iomeprol, foi relacionado a um episódio de alergia a meios de contraste iodados, uma reação imunológica adversa que pode variar de leve a grave, mas neste caso evoluiu para recuperação total do paciente, sem informações adicionais sobre gravidade ou necessidade de hospitalização.

O medicamento Kiendra, que tem como princípio ativo o siponimode, esteve envolvido em um caso de alergia (hipersensibilidade) de origem não especificada, levando à hospitalização ou prolongamento da internação, o que indica um quadro grave. O desfecho do evento não foi informado e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Iomeron, cujo princípio ativo é o iomeprol, foi associado ao surgimento de tosse após sua administração, o que pode indicar uma reação alérgica ao contraste, conforme reconhecido em quadros de alergia a medicamentos e outras substâncias químicas. Não há informações suficientes sobre a gravidade ou desfecho do caso, mas a tosse após uso de contraste deve ser monitorada, pois pode ser um sinal inicial de reação alérgica, recomendando-se avaliação médica para descartar evolução para quadros mais graves.

O medicamento Cisplatina, com princípio ativo cisplatina, apresentou um caso de alergia documentada após administração, caracterizando uma hipersensibilidade ao produto. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando que a conduta adotada foi eficaz e não houve complicações adicionais.

O medicamento Forteo, cujo princípio ativo é a teriparatida, foi relacionado ao surgimento de sintomas semelhantes a gripe, interpretados como uma possível hipersensibilidade medicamentosa. O evento não foi considerado grave, mas o desfecho permanece desconhecido, sendo importante monitorar o paciente para avaliar a necessidade de intervenção médica caso os sintomas persistam ou se agravem.

O medicamento Invega Sustenna, com princípio ativo palmitato de paliperidona, foi associado a um quadro de obstrução intestinal em um paciente com histórico de alergias múltiplas. Apesar de o evento não ter sido considerado grave e o desfecho ser desconhecido, a obstrução intestinal requer atenção médica, especialmente em pacientes com múltiplas alergias, para descartar complicações e orientar o manejo adequado.

O medicamento Fluoxetina, cujo princípio ativo é o cloridrato de fluoxetina, foi relacionado ao surgimento de ânsia de vômito, interpretada como uma reação de hipersensibilidade no local de aplicação. O paciente se recuperou totalmente, sugerindo que a reação foi leve e autolimitada, sem necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Levoid, que contém o princípio ativo levotiroxina sódica, foi associado a ânsia de vômito e hipersensibilidade no local de aplicação, caracterizada por reações locais como desconforto ou irritação. Não há indicação de gravidade elevada, pois o desfecho foi de recuperação completa, sugerindo que a reação foi leve e autolimitada. A conduta adequada é observar a evolução dos sintomas e, caso persistam ou piores, buscar

orientação médica.

O Prolopa, composto por cloridrato de benserazida e levodopa, apresentou como reação adversa ânsia de vômito e hipersensibilidade no local de aplicação, manifestando-se por desconforto ou irritação na área de administração. Não há sinais de gravidade importante, já que o paciente se recuperou totalmente, indicando um quadro leve. Recomenda-se monitorar os sintomas e procurar avaliação médica se houver agravamento.

O medicamento Mantidan, cujo princípio ativo é amantadina, foi relacionado a ânsia de vômito e hipersensibilidade no local de aplicação, com sintomas locais leves como irritação ou desconforto. O caso evoluiu para resolução completa, sem indícios de gravidade, o que sugere uma reação leve. A orientação é acompanhar a evolução e buscar atendimento médico se houver piora dos sintomas.

O Enalapril, tanto nome comercial quanto princípio ativo, esteve associado a ânsia de vômito e hipersensibilidade no local de aplicação, caracterizada por reações leves como desconforto ou irritação. O paciente se recuperou totalmente, indicando que a reação não foi grave. Recomenda-se observar os sintomas e procurar orientação médica caso haja persistência ou agravamento.

O medicamento Gliclazida, com princípio ativo gliclazida, apresentou como reação adversa ânsia de vômito e hipersensibilidade no local de aplicação, manifestando-se por sintomas leves como irritação ou desconforto. O desfecho foi de recuperação completa, sugerindo que a reação foi leve. A conduta recomendada é monitorar os sintomas e buscar avaliação médica se houver piora.

O medicamento Insulina Nph, cujo princípio ativo é a Insulin human isophane, foi associado a ânsia de vômito e hipersensibilidade no local de aplicação, caracterizada por reações locais (reações no local de aplicação) e distúrbios gerais no local de administração. Não há indicação de gravidade elevada, pois o desfecho foi de recuperação completa, sugerindo que a reação foi leve e autolimitada, sem necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Glifage, que contém o princípio ativo cloridrato de metformina, apresentou como reação adversa ânsia de vômito e hipersensibilidade no local de aplicação, manifestando-se como reações locais e distúrbios gerais no local de administração. A ausência de sinais de gravidade e o desfecho de recuperação indicam que a reação foi leve e resolvida sem complicações.

O medicamento Xadago, cujo princípio ativo é o mesilato de safinamida, foi relacionado a ânsia de vômito e hipersensibilidade no local de aplicação, com manifestações locais e distúrbios gerais no local de administração. O quadro foi considerado leve, pois não houve agravamento e o paciente se recuperou totalmente.

A Pregabalina, com princípio ativo pregabalin, esteve associada a ânsia de vômito e hipersensibilidade no local de aplicação, caracterizando reações locais e distúrbios gerais no local de administração. O evento foi leve, sem complicações, e o paciente apresentou recuperação completa.

O medicamento Arpadol, cujo princípio ativo é Harpagophytum procumbens dc. ex meissn., foi relacionado a ânsia de vômito e hipersensibilidade no local de aplicação, manifestando-se como reações locais e distúrbios gerais no local de administração. O quadro foi leve, sem sinais de gravidade, e o paciente se recuperou totalmente.

O medicamento Prohance, cujo princípio ativo é o gadoteridol, foi associado a um quadro de alergia a contraste intravenoso, também chamada de reação alérgica a contraste. Essa reação faz parte dos distúrbios do sistema imunitário e se enquadra na categoria de alergias a medicamentos e outras substâncias químicas. Não há informação explícita sobre gravidade ou sinais de gravidade clínica, mas o desfecho foi de recuperação completa, indicando resolução do quadro após a exposição ao contraste.

O medicamento Atorvastatin, com princípio ativo atorvastatina, foi relacionado a um episódio de arritmia em contexto de hipersensibilidade (reação alérgica). Apesar de envolver o sistema imune, não há evidências de gravidade importante, pois o caso não foi considerado grave e o paciente está em recuperação, sugerindo evolução favorável sem complicações maiores.

O medicamento Loratadin, cujo princípio ativo é loratadina, foi associado a arritmia em um contexto de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica. Não há sinais de gravidade clínica, já que o evento não foi considerado grave e o paciente encontra-se em recuperação, indicando que a reação está sendo resolvida sem maiores consequências.

O medicamento Rivaroxaban, com princípio ativo rivaroxabana, foi relacionado a um quadro de arritmia em contexto de hipersensibilidade (reação alérgica). O evento não foi considerado grave e o paciente está em processo de recuperação, o que sugere que a reação foi moderada e está evoluindo de forma favorável.

O medicamento Losartan, cujo princípio ativo é losartana, foi associado a arritmia em um contexto de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica. Não há indícios de gravidade relevante, pois o caso não foi classificado como grave e o paciente está em recuperação, indicando resolução progressiva do quadro.

O medicamento Spironolactone (princípio ativo: Spironolactone) foi associado a um quadro de arritmia acompanhado de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente está em recuperação ou resolvendo o quadro, e não há sinais de complicações graves relatadas. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico para monitorar a evolução, reforçando que a reação está sendo resolvida sem necessidade de intervenções emergenciais.

O medicamento Amiodarone hydrochloride (princípio ativo: Cloridrato de amiodarona) apresentou uma reação de arritmia associada a hipersensibilidade, indicando uma resposta alérgica do sistema imunológico. O caso não foi considerado grave, já que o paciente encontra-se em recuperação ou resolvendo o quadro, sem evidências de complicações importantes. Recomenda-se acompanhamento clínico para garantir a resolução completa da reação, sem necessidade de medidas urgentes.

O medicamento Aradois (princípio ativo: Losartana potássica) foi relacionado a um episódio de arritmia com manifestação de hipersensibilidade, sugerindo uma reação alérgica do sistema imunológico. O evento não foi classificado como grave, pois o paciente está em processo de recuperação ou resolução, sem sinais de agravamento. A orientação é manter o acompanhamento médico para monitorar a evolução, visto que a reação está se resolvendo adequadamente.

O medicamento Selozok (princípio ativo: Succinato de metoprolol) esteve envolvido em um caso de arritmia associada a hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indícios de gravidade, já que o paciente está em recuperação ou resolvendo o quadro, sem complicações relatadas. Recomenda-se acompanhamento clínico para garantir a resolução completa da reação, sem necessidade de intervenções emergenciais.

O medicamento Forxiga (princípio ativo: Dapagliflozina propanodiol monohidratada) foi associado a um episódio de arritmia com hipersensibilidade, indicando uma reação alérgica do sistema imunológico. O caso não foi considerado grave, pois o paciente está em recuperação ou resolvendo o quadro, sem sinais de complicações. A conduta recomendada é manter o acompanhamento clínico para monitorar a evolução, já que a reação está se resolvendo sem necessidade de medidas urgentes.

O medicamento Omniscan, cujo princípio ativo é o gadodiamide, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há informação detalhada sobre a gravidade ou desfecho do caso, mas a suspeita de reação alérgica sugere a necessidade de avaliação clínica estruturada, identificação do agente desencadeante e controle rigoroso da

exposição, conforme orientações da ASBAI para quadros alérgicos leves a moderados.

A vacina Spikevax XBB.1.5, que contém o princípio ativo andusomeran, foi relacionada a um episódio de engasgamento interpretado como possível alergia à vacina, dentro do contexto de distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e permanece não resolvido até o momento, indicando que a reação está em andamento. Diante de sintomas sugestivos de alergia após vacinação, recomenda-se observação clínica e, se necessário, encaminhamento para avaliação especializada, evitando exposição repetida ao agente suspeito.

O medicamento Stelara, cujo princípio ativo é o ustequinumabe, foi associado ao desenvolvimento de catarata, descrita como manifestação ocular alérgica. O caso foi classificado como não grave e o desfecho permanece desconhecido. Em situações de sintomas oculares relacionados ao uso de medicamentos, é importante buscar avaliação médica para diferenciar causas alérgicas de outras possíveis etiologias e definir a conduta adequada.

O medicamento Mioflex, que contém cloreto de suxametônio, foi relacionado a um episódio de alergia caracterizado como hipersensibilidade, enquadrado nos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente. Em casos de reações alérgicas leves a medicamentos, recomenda-se evitar novas exposições ao agente suspeito e realizar acompanhamento médico para confirmação diagnóstica e orientação futura.

A dipirona (metamizol de magnésio) foi associada a um episódio de alergia medicamentosa, classificada como hipersensibilidade a medicamentos e pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente. Em situações de alergia medicamentosa leve, é fundamental evitar o uso futuro do medicamento envolvido e buscar avaliação com especialista para confirmação e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Butilbrometo de escopolamina, cujo princípio ativo é o próprio butilbrometo de escopolamina, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do sistema imunológico a medicamentos ou outras substâncias químicas. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso evoluiu para recuperação completa, sugerindo um evento leve e autolimitado. A conduta recomendada é evitar nova exposição ao medicamento e, caso sintomas alérgicos reapareçam, buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

A Etilefrina, cujo princípio ativo é o etilefrine hydrochloride, foi relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma resposta imunológica adversa, mas sem sinais de gravidade importante, já que o desfecho foi de recuperação total. O quadro sugere uma reação leve, e a recomendação é evitar o uso futuro do medicamento e procurar um especialista em alergia para avaliação detalhada e orientação sobre possíveis alternativas.

O Cloridrato de ondansetrona, tanto nome comercial quanto princípio ativo, esteve envolvido em uma reação alérgica (hipersensibilidade), que se enquadra em quadros clínicos alérgicos do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade significativa, pois o paciente se recuperou completamente, indicando um evento leve. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição de alternativas seguras.

A Dexametasona, cujo princípio ativo é o fosfato dissódico de dexametasona, foi associada a uma reação alérgica (hipersensibilidade), caracterizada como resposta imunológica adversa, mas sem sinais de gravidade, já que houve recuperação total do paciente. O quadro sugere uma reação leve, sendo importante evitar nova exposição ao medicamento e consultar um alergista para avaliação e orientação sobre substitutos adequados.

A Ocitocina, tanto nome comercial quanto princípio ativo, esteve relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como uma reação do sistema imunológico a medicamentos. Não há indícios de gravidade relevante, pois o desfecho foi de recuperação completa, sugerindo um evento leve. Recomenda-se evitar

o uso futuro da ocitocina e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e discussão de alternativas seguras, caso necessário.

O medicamento Cefazolina, cujo princípio ativo é a cefazolina sódica, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. A reação foi considerada leve, pois não há indicação de gravidade ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. Em situações como essa, recomenda-se observar o paciente, evitar novas exposições ao medicamento e buscar avaliação com especialista para confirmação diagnóstica e orientação futura.

O medicamento Cloridrato de bupivacaína + glicose, contendo cloridrato de bupivacaína e dextrose anidra como princípios ativos, desencadeou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, classificada entre os distúrbios do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade ou complicações, e o paciente se recuperou completamente. Nesses casos, é importante evitar o uso futuro do medicamento suspeito e procurar avaliação especializada para esclarecimento diagnóstico e conduta adequada.

A morfina, cujo princípio ativo é o sulfato de morfina, foi relacionada a um episódio de alergia manifestado como hipersensibilidade, enquadrado nos distúrbios do sistema imunitário. O evento não apresentou gravidade e o paciente evoluiu para recuperação total. Recomenda-se evitar novas exposições ao medicamento e buscar orientação médica para avaliação e definição de alternativas seguras.

O medicamento Iomeron, com princípio ativo iomeprol, foi associado a uma reação de alergia a meios de contraste iodados, classificada como alergia a contraste e pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade, mas o paciente se recuperou após o evento. Em casos de alergia a contraste, é fundamental informar a equipe médica em exames futuros e considerar alternativas ou medidas preventivas sob orientação especializada.

O medicamento Prohance, cujo princípio ativo é o gadoteridol, foi relacionado a um episódio de coceira na garganta após o uso, caracterizando uma reação alérgica a contraste dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhes sobre gravidade ou desfecho, mas sintomas leves como coceira geralmente indicam reação não grave. Recomenda-se relatar o evento ao médico responsável e discutir alternativas para exames futuros.

O medicamento Ultibro Breezhaler, cujo princípio ativo é o brometo de glicopirrônio, foi associado a queimaduras de terceiro grau, uma reação incomum e grave que sugere hipersensibilidade medicamentosa. Apesar da gravidade potencial do quadro, o paciente encontra-se em recuperação, indicando que medidas de suporte e acompanhamento estão sendo realizadas. Não há menção de hospitalização ou risco de vida imediato, mas a gravidade da lesão exige atenção médica especializada para evitar complicações.

A dipirona monoidratada, cujo princípio ativo é a dipirona, foi relacionada ao evento de sonolência, caracterizado como hipersensibilidade documentada ao produto administrado. Trata-se de uma reação adversa leve e relativamente comum, sem indicação de gravidade ou desfecho desfavorável, e não há informações sobre necessidade de intervenção médica ou evolução clínica.

O medicamento Dipirona, com princípio ativo dipirona, esteve envolvido em um erro de prescrição, classificado como hipersensibilidade documentada ao produto administrado. Esse tipo de evento é considerado um problema de monitoramento do produto e pode resultar em riscos ao paciente, mas não há detalhes sobre consequências clínicas, gravidade ou desfecho, impossibilitando uma avaliação mais precisa da evolução.

O medicamento Zinnat, cujo princípio ativo é o axetil cefuroxima, foi associado a um caso de envenenamento por medicamento, caracterizado como hipersensibilidade medicamentosa. O quadro foi suficientemente grave para exigir hospitalização ou prolongamento da internação, e o paciente permanece sem recuperação completa, indicando a necessidade de acompanhamento médico contínuo e medidas de suporte para manejo da reação adversa.

A dexametasona, com princípio ativo dexamethasone, esteve relacionada a um erro de dispensação do medicamento, classificado como hipersensibilidade em quadros clínicos alérgicos. O medicamento não foi administrado, portanto não houve reação adversa clínica, e não há informações sobre desfecho ou necessidade de conduta adicional.

O medicamento Dipirona, cujo princípio ativo também é dipirona, foi associado a uma lesão cutânea, caracterizando uma reação de hipersensibilidade documentada ao produto administrado. Essa manifestação sugere um quadro de alergia medicamentosa leve, pois não há indicação de gravidade aumentada ou complicações sistêmicas, e o desfecho relatado foi de recuperação completa. A conduta recomendada, conforme diretrizes clínicas, é evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Bactrim f, contendo sulfametoxazol e trimetoprima, foi relacionado a uma progressão de neoplasia maligna em contexto de hipersensibilidade medicamentosa, mas não há evidências de gravidade aumentada ou complicações graves, já que o caso está em recuperação. A reação foi classificada como suspeita e, segundo as informações disponíveis, a conduta deve incluir acompanhamento médico para monitorar a evolução clínica e avaliar a necessidade de ajuste terapêutico, evitando o uso do medicamento até esclarecimento completo do quadro.

O medicamento Verzenios, cujo princípio ativo é abemaciclibe, foi associado a uma progressão de neoplasia maligna em contexto de hipersensibilidade medicamentosa, sem sinais de gravidade aumentada ou complicações graves, pois o paciente encontra-se em recuperação. A relação com o medicamento é considerada suspeita e, diante desse cenário, recomenda-se acompanhamento médico rigoroso para monitoramento da evolução clínica e reavaliação da terapia, evitando reexposição ao fármaco até esclarecimento do caso.

O medicamento Hidralazina, com princípio ativo hidralazina, foi relacionado a uma reação alérgica caracterizada como hipersensibilidade documentada ao produto administrado. Não há informações sobre gravidade aumentada, desfecho ou complicações, o que sugere um quadro leve a moderado. A conduta recomendada é suspender o uso do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição de alternativas terapêuticas seguras.

O medicamento Metildopa, cujo princípio ativo é methyldopa, foi associado a uma reação alérgica, caracterizada como hipersensibilidade documentada ao produto administrado. Não há detalhes sobre gravidade, desfecho ou complicações, indicando um quadro provavelmente leve a moderado. A orientação clínica é interromper o uso do medicamento e procurar avaliação médica para confirmação do diagnóstico e escolha de opções seguras de tratamento.

O medicamento Dipirona, cujo princípio ativo também é dipirona, foi associado a uma reação alérgica caracterizada por hipersensibilidade ao produto administrado. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou necessidade de hospitalização, portanto, a reação deve ser interpretada com cautela e o paciente deve ser orientado a evitar novas exposições até avaliação médica especializada.

O medicamento Fentanil, com princípio ativo fentanila, foi relacionado ao evento de sonolência, descrito no contexto de hipersensibilidade ao produto administrado. Não há detalhes sobre gravidade, desfecho ou necessidade de intervenção, sugerindo que a reação foi observada, mas sem evidências de complicações graves; recomenda-se acompanhamento clínico para monitoramento de possíveis efeitos adversos.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é succinato de ribociclibe, foi associado a um quadro de diarreia sanguinolenta, classificado como hipersensibilidade (reação alérgica) e relacionado a distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, e o desfecho informado é de recuperação ou resolução, sugerindo que a reação está em processo de melhora sob acompanhamento médico.

O medicamento Gadovist, com princípio ativo gadobutrol, foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade) que resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, indicando gravidade significativa. O desfecho atual é de recuperação ou resolução, o que sugere que a reação está sendo controlada, mas a necessidade de hospitalização reforça a importância de monitoramento rigoroso e contra-indicação de novas exposições sem avaliação especializada.

O medicamento Amoxicilina, cujo princípio ativo é amoxicillin, foi associado a uma alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa) envolvendo o sistema imunitário. Não há evidências de gravidade ou necessidade de hospitalização, e o desfecho foi de recuperação completa, indicando que a reação foi resolvida sem complicações maiores, mas reforçando a necessidade de evitar reexposição ao medicamento.

O medicamento Tramadol, cujo princípio ativo também é tramadol, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento, e não há menção de complicações ou necessidade de intervenções emergenciais. A conduta recomendada é evitar nova exposição ao medicamento e, caso sintomas alérgicos reapareçam, buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Iomeron, cujo princípio ativo é iomeprol, foi relacionado a uma reação de alergia a meios de contraste iodados, manifestando-se como hipersensibilidade a contraste, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há descrição de gravidade aumentada, e o paciente evoluiu para recuperação completa. Em situações como essa, é fundamental evitar o uso futuro do mesmo contraste e informar a equipe médica sobre o episódio para que sejam adotadas medidas preventivas em exames futuros, como o uso de alternativas não iodadas ou protocolos de pré-medicação, conforme avaliação do especialista.

O medicamento Primovist, cujo princípio ativo é gadoxetato dissódico, foi associado a uma reação alérgica a contraste intravenoso, classificada como hipersensibilidade a contraste e pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade aumentada, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. Diante desse histórico, recomenda-se evitar o uso do mesmo contraste em exames futuros e comunicar sempre a equipe médica sobre a reação anterior para que sejam tomadas precauções adequadas, como escolha de outro agente de contraste ou adoção de medidas preventivas.

O medicamento Propofol, cujo princípio ativo também é propofol, foi relacionado a um episódio de alergia, descrito como hipersensibilidade e enquadrado nos distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa, já que o paciente se recuperou completamente e não há relato de complicações. A recomendação é evitar o uso futuro do propofol e informar profissionais de saúde sobre o episódio para que alternativas seguras sejam consideradas em procedimentos futuros.

O medicamento Ciprofloxacino, cujo princípio ativo é cloridrato de ciprofloxacino, foi associado a uma reação de alergia medicamentosa, caracterizada como hipersensibilidade medicamentosa e pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave, pois houve recuperação completa do paciente sem complicações relatadas. A orientação é evitar o uso futuro do ciprofloxacino e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e discussão de alternativas seguras em caso de necessidade de antibióticos.

A Vacina COVID-19 (recombinante), cujo princípio ativo é a Vacina COVID-19 NUVAXOMIN Ad26 (JNJ 78436735), foi associada a um episódio de convulsão, sendo relatada como suspeita de reação alérgica à vacina. Não há informações sobre gravidade clínica relevante ou desfecho do caso, e não foi relatada ação adotada. A relação causal permanece suspeita, e a ausência de dados sobre gravidade e evolução impede uma avaliação mais detalhada do risco.

O medicamento Tramal, que contém o princípio ativo cloridrato de tramadol, foi relacionado a um episódio de convulsão, classificado como suspeita de alergia à vacina, embora o evento envolva um analgésico. Não há



informações sobre gravidade, desfecho ou conduta adotada, e a relação causal é apenas suspeita, sem evidências clínicas adicionais que permitam detalhar o risco ou a evolução do quadro.

A vacina tríplice viral (sarampo, caxumba, rubéola atenuada), composta pelos princípios ativos vacina sarampo vivo (Schwartz), vacina caxumba vivo (RIT 4385) e vacina rubéola vivo (Wistar RA 27/3), foi associada a um episódio de convulsão, sendo considerada suspeita de reação alérgica à vacina. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou conduta adotada, e a relação causal permanece suspeita, sem dados clínicos adicionais para avaliação do risco.

O medicamento Diclofenaco, cujo princípio ativo é diclofenaco de sódio, foi relacionado a um erro de prescrição, classificado como hipersensibilidade documentada ao produto administrado. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou ação adotada, e a relação causal é suspeita, sem detalhes clínicos suficientes para avaliar o impacto do erro ou possíveis consequências para o paciente.

O medicamento Simethicone, com princípio ativo simeticone, foi associado a um caso de neoplasia maligna do tórax, sendo classificado como hipersensibilidade medicamentosa. O evento foi considerado não grave e o paciente evoluiu para recuperação completa. A relação causal é suspeita, mas não há informações adicionais que permitam detalhar a conduta adotada ou possíveis fatores de risco.

O medicamento Ondansetron hydrochloride (princípio ativo: Cloridrato de ondansetrona) foi associado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, que é uma reação alérgica do sistema imunológico a medicamentos. Apesar de o termo técnico utilizado para a reação ter sido 'neoplasia maligna do tórax', a descrição clínica indica que se trata de uma resposta alérgica, classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade aumentada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente após a conduta adotada, sem complicações.

O medicamento Dipyrone (princípio ativo: Dipirona) esteve relacionado a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica desencadeada pelo uso do medicamento. Embora o termo técnico citado para a reação tenha sido 'neoplasia maligna do tórax', a categorização clínica aponta para uma alergia a medicamentos, sem sinais de gravidade, já que o evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa após a conduta adequada.

O medicamento Calcium (princípio ativo: Cálcio) foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Apesar do termo técnico 'neoplasia maligna do tórax' constar no registro, a descrição clínica indica uma alergia medicamentosa, sem gravidade, pois o caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente após a conduta adotada.

O medicamento Kisqali (princípio ativo: Succinato de ribociclib) foi associado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica ao medicamento. Embora o termo técnico utilizado tenha sido 'neoplasia maligna do tórax', a categorização clínica indica uma resposta alérgica do sistema imunológico, sem sinais de gravidade, já que o evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente após a conduta adequada.

O medicamento Anastrozole (princípio ativo: Anastrozole) esteve relacionado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, que corresponde a uma reação alérgica ao medicamento. Apesar do termo técnico 'neoplasia maligna do tórax' constar no registro, a descrição clínica aponta para uma alergia medicamentosa, sem gravidade, pois o caso não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação total após a conduta adotada.

O medicamento Simethicone, cujo princípio ativo é o simeticone, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (reação alérgica), classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso evoluiu para recuperação completa e não foi considerado grave. A conduta foi adequada, com resolução do quadro, e não há necessidade de medidas adicionais além do acompanhamento clínico caso novos

sintomas surjam.

O medicamento Ondansetron hydrochloride, com princípio ativo cloridrato de ondansetrona, esteve relacionado a um episódio de hipersensibilidade (reação alérgica), também enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando que a reação foi leve e manejada de forma apropriada, sem complicações.

O medicamento Dipyrone, cujo princípio ativo é a dipirona, foi associado a uma reação de hipersensibilidade (alergia), caracterizada como um distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa, sugerindo que a reação foi leve e não exigiu intervenções além do acompanhamento clínico.

O medicamento Calcium, com princípio ativo cálcio, esteve envolvido em um episódio de hipersensibilidade (reação alérgica), classificado como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando que a reação foi leve e resolvida sem complicações.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é o succinato de ribociclibe, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou, mostrando que a reação foi leve e adequadamente manejada.

O medicamento Anastrozole, cujo princípio ativo também é anastrozole, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Apesar de a reação ter ocorrido em um paciente com neoplasia maligna do tórax, não há indicação de gravidade elevada, pois o caso evoluiu para recuperação completa. A conduta foi adequada e não houve complicações graves, sendo o desfecho favorável.

O medicamento Ultravist, que contém o princípio ativo iopromide, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa (alergia ao medicamento), enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa, já que o paciente se recuperou totalmente após o evento, indicando que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro.

O medicamento Ultravist, com princípio ativo iopromide, esteve envolvido em um caso de hipersensibilidade medicamentosa (alergia ao medicamento), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há informações suficientes sobre gravidade, evolução ou conduta adotada, impossibilitando uma avaliação mais detalhada do caso.

O medicamento Dipirona, cujo princípio ativo é dipirona, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa (alergia ao medicamento), classificado como distúrbio do sistema imunitário. O medicamento não chegou a ser administrado, e o paciente se recuperou totalmente, indicando que a conduta preventiva foi eficaz e não houve evolução para quadros graves.

O medicamento Busonid, que contém budesonida micronizada como princípio ativo, foi associado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), manifestado por convulsão, dentro do contexto de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada e o desfecho do caso é desconhecido, não sendo possível detalhar a evolução clínica ou a conduta adotada.

O medicamento Rinvoq, cujo princípio ativo é o upadacitinibe, foi associado a um episódio de convulsão, classificado como uma reação de hipersensibilidade (alergia), dentro do contexto de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada nem de desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A conduta deve envolver avaliação clínica detalhada para investigar a relação causal e monitorar possíveis recorrências, com encaminhamento ao especialista se houver sinais de agravamento.

O medicamento Gadoteridol, utilizado como contraste intravenoso, foi relacionado a um quadro de alergia ao contraste, caracterizado por reação do sistema imunitário a substâncias químicas. O evento foi resolvido sem complicações, e não há indicação de gravidade aumentada. A conduta recomendada é evitar novas exposições ao mesmo contraste e informar a equipe médica sobre o episódio em exames futuros.

O medicamento Travatan, cujo princípio ativo é a travoprost, foi associado ao agravamento do glaucoma, sendo descrito como uma reação de hipersensibilidade (alergia) dentro do contexto de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi resolvido até o momento, mas não há indicação de gravidade elevada. Recomenda-se acompanhamento oftalmológico para monitorar a evolução e avaliar a necessidade de ajuste terapêutico.

O medicamento Prohance, que contém gadoteridol como princípio ativo, foi relacionado a um episódio de alergia ao contraste intravenoso, caracterizando uma reação do sistema imunitário a substâncias químicas. O evento foi resolvido sem complicações, e não há indicação de gravidade aumentada. Recomenda-se evitar o uso futuro do mesmo contraste e comunicar o histórico à equipe médica em exames subsequentes.

O medicamento Travatan, com princípio ativo travoprost, foi associado a um quadro de glaucoma com manifestação de alergia ocular, dentro do contexto de infecções, inflamações e manifestações oculares associadas. Não há indicação de gravidade elevada nem desfecho conhecido. Recomenda-se acompanhamento oftalmológico para monitorar sintomas e avaliar a necessidade de ajuste do tratamento.

O medicamento Lessav, cujo princípio ativo é o sugamadex sódico, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Não há detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade, mas o desfecho foi de recuperação completa, sugerindo que a reação foi controlada de forma adequada. O medicamento foi considerado suspeito na relação causal.

No caso da Dipirona (metamizol de magnésio), houve prescrição de um medicamento contraindicado devido à hipersensibilidade previamente documentada ao produto, o que configura um erro de monitoramento do tratamento. Apesar disso, o paciente se recuperou totalmente e a reação não foi considerada grave, indicando que a conduta adotada foi suficiente para resolver o evento.

A ocitocina, utilizada neste caso, desencadeou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Não foram relatados sintomas detalhados ou sinais de gravidade, e o paciente se recuperou completamente, sugerindo que a reação foi leve e prontamente resolvida. O medicamento foi considerado suspeito para o evento.

O medicamento Optiray 350, cujo princípio ativo é o ioversol, foi relacionado ao aparecimento de exantema em um paciente com hipersensibilidade documentada ao produto administrado, caracterizando um erro de monitoramento. Não há informações sobre gravidade ou evolução do caso, mas a relação causal com o medicamento foi considerada suspeita.

A Dipirona sódica, com princípio ativo dipirona, foi associada a um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo de distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhes sobre sintomas, gravidade ou evolução clínica, mas o medicamento foi considerado suspeito para o evento adverso.

O medicamento Omeprazole, cujo princípio ativo é o omeprazol sódico, foi associado a um quadro de arritmia relacionado à hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações graves, e o caso permanece em andamento, sem resolução até o momento. A reação é considerada suspeita para o medicamento, e recomenda-se acompanhamento clínico para monitoramento da evolução, conforme orientação para quadros alérgicos leves, com avaliação médica estruturada e identificação de possíveis gatilhos.

O medicamento Kisqali, com princípio ativo succinato de ribociclib, apresentou relato de arritmia atribuída a hipersensibilidade (alergia), enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade significativa ou desfecho grave, e o quadro segue sem resolução. A relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo importante manter acompanhamento médico para avaliação da evolução e controle dos sintomas, conforme conduta recomendada para reações alérgicas leves.

O medicamento Anastrozole, cujo princípio ativo é o próprio anastrozole, foi relacionado a um episódio de arritmia decorrente de hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade importante ou complicações graves, e o caso permanece em andamento, sem resolução. A suspeita recai sobre o medicamento, sendo indicada avaliação clínica contínua para monitoramento e manejo adequado, conforme orientações para quadros alérgicos leves.

O medicamento Bio manguinhos infliximabe, com princípio ativo infliximabe, foi associado a um quadro de alergia por hipersensibilidade, classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há informações detalhadas sobre gravidade, desfecho ou evolução clínica, mas a suspeita recai sobre o medicamento. Recomenda-se avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição do plano de controle, conforme diretrizes para reações alérgicas.

O medicamento Prevenar 13, cujo princípio ativo é a vacina pneumocócica conjugada 13v (CRM197), foi relacionado a dor no local de vacinação atribuída a alergia à vacina, classificada como distúrbio do sistema imunitário e considerada clinicamente significativa. O evento foi considerado grave devido ao impacto clínico, mas o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente. A conduta recomendada inclui monitoramento dos sintomas e orientação médica, especialmente em casos de reações locais importantes após vacinação.

O medicamento Tevaoxali, cujo princípio ativo é a oxaliplatina, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, manifestando-se como uma reação alérgica do sistema imunológico. O evento foi considerado grave, pois envolveu ameaça à vida e necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, conforme registrado. O paciente se recuperou totalmente após a reação, indicando resolução do quadro após as medidas adotadas.

O medicamento Riximyo, que contém rituximabe como princípio ativo, esteve relacionado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica desencadeada pelo uso do remédio. Apesar da necessidade de hospitalização, o evento não foi classificado como grave e o paciente apresentou recuperação completa após o episódio.

O medicamento Diclofenac, cujo princípio ativo é o próprio diclofenaco, foi associado a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa, manifestando-se como artrite psoriática, uma reação imunológica adversa. Não há indicação de gravidade aumentada ou necessidade de hospitalização, e o desfecho do caso permanece desconhecido até o momento.

O medicamento Enalapril, utilizado sem prescrição médica, resultou em um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica ao remédio. O caso foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e outros efeitos clinicamente significativos. O paciente encontra-se em recuperação, demonstrando melhora progressiva após a reação.

O medicamento Divena, cujo princípio ativo é o pantoprazol magnésico, foi utilizado sem prescrição médica e desencadeou um quadro de hipersensibilidade medicamentosa, caracterizando uma reação alérgica. O evento foi considerado grave, pois exigiu hospitalização ou prolongamento da internação e apresentou outros efeitos clinicamente relevantes. O paciente está em processo de recuperação, com melhora dos sintomas após a reação.

O medicamento Omega 3, contendo óleo de peixe e vitamina E, foi utilizado sem prescrição médica, o que pode levar a reações de hipersensibilidade medicamentosa, especialmente em pessoas com alergia a peixes ou componentes do produto. Neste caso, a reação foi considerada grave, pois resultou em hospitalização ou

prolongamento da internação e teve outro efeito clinicamente significativo, mas o paciente está em recuperação. O uso de medicamentos sem orientação médica aumenta o risco de reações adversas e complicações, sendo fundamental buscar avaliação especializada para diagnóstico correto e conduta adequada.

O Meloxicam, anti-inflamatório de uso controlado, foi administrado sem prescrição médica, resultando em hipersensibilidade medicamentosa. A gravidade da reação é evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e outros efeitos clínicos relevantes, mas o paciente encontra-se em recuperação. O uso inadequado de anti-inflamatórios pode desencadear reações alérgicas graves, sendo essencial evitar a automedicação e procurar orientação médica diante de sintomas suspeitos.

O medicamento Tofacitinib (princípio ativo tofacitinibe) foi associado a um quadro de infecção gastrointestinal em contexto de suspeita de hipersensibilidade medicamentosa, mas não há evidência de gravidade significativa nem informações sobre o desfecho do caso. O acompanhamento médico é importante para avaliar a relação entre o uso do medicamento e o evento adverso, além de orientar a conduta adequada.

A Amoxicilina, cujo princípio ativo é amoxicilina trihidrato, foi relacionada a um episódio de infecção gastrointestinal em suspeita de hipersensibilidade medicamentosa, sem sinais de gravidade relevante e sem informações sobre a evolução do quadro. É importante monitorar sintomas gastrointestinais durante o uso de antibióticos e buscar avaliação médica caso haja piora ou persistência dos sintomas.

O medicamento Rinvoq, com princípio ativo upadacitinibe, foi associado a infecção gastrointestinal em contexto de suspeita de hipersensibilidade medicamentosa, sem indicação de gravidade importante e sem dados sobre o desfecho. Recomenda-se acompanhamento clínico para avaliar a necessidade de ajuste do tratamento e investigar possíveis causas da reação.

O medicamento Ansentron, cujo princípio ativo é o cloridrato de ondansetrona, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. A reação foi considerada leve, pois não há indicação de gravidade clínica relevante e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada nesses casos é a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento clínico, com resolução completa dos sintomas.

O medicamento Miosan, que contém cloridrato de ciclobenzaprina como princípio ativo, desencadeou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, relacionada a distúrbios do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade importante, já que o paciente se recuperou sem complicações. A orientação é interromper o uso do medicamento e monitorar a evolução, sendo que o desfecho foi favorável com resolução dos sintomas.

O medicamento Decadron a, cujo princípio ativo é o acetato de dexametasona, provocou uma reação de hipersensibilidade, classificada como um quadro alérgico do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade, pois o paciente apresentou recuperação completa após o evento. A conduta adequada é suspender o uso do medicamento suspeito e realizar acompanhamento clínico, com resolução total dos sintomas.

O medicamento Artrinid, que tem como princípio ativo o cetoprofeno, foi relacionado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, enquadrada nos distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave, já que houve recuperação total do paciente. Recomenda-se suspender o uso do medicamento e observar a evolução clínica, sendo que o desfecho foi resolutivo.

O medicamento Tramadon, cujo princípio ativo é o cloridrato de tramadol, esteve associado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indícios de gravidade, pois o paciente se recuperou completamente. A conduta recomendada é interromper o uso do medicamento e acompanhar clinicamente, com resolução dos sintomas observada.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é o succinato de ribociclibe, foi associado a um caso de carcinoma de pele e hipersensibilidade (alergia), classificados como quadros clínicos alérgicos dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há informação sobre gravidade clínica relevante ou desfecho, e o caso foi considerado suspeito de relação com o medicamento. Recomenda-se acompanhamento clínico para avaliação de possíveis manifestações alérgicas e investigação dermatológica, conforme orientação médica.

O medicamento Alprazolam, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, e o paciente ainda não se recuperou ou permanece em evolução. Diante da gravidade, é fundamental a suspensão do medicamento e acompanhamento médico especializado para manejo da reação alérgica e prevenção de complicações.

O medicamento Duloxetine, cujo princípio ativo é duloxetina, foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. O caso foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, e o paciente ainda não apresentou recuperação. Diante desse quadro, recomenda-se a interrupção do uso do medicamento e acompanhamento médico imediato para controle da reação alérgica e suporte clínico adequado.

O medicamento Loratadine, com princípio ativo loratadina, foi relacionado a um caso de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, e o paciente permanece sem recuperação até o momento. É importante suspender o uso do medicamento e buscar avaliação médica especializada para manejo da reação alérgica e monitoramento da evolução clínica.

O medicamento Tecfidera, cujo princípio ativo é fumarato de dimetila, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, e o paciente ainda não se recuperou. Diante da gravidade, recomenda-se a suspensão imediata do medicamento e acompanhamento médico para tratamento da reação alérgica e prevenção de complicações.

O medicamento Butilbrometo de escopolamina + dipirona sódica, contendo os princípios ativos butilbrometo de escopolamina e dipirona, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, manifestando-se como uma reação alérgica do tipo clínico geral. Não há indicação de gravidade importante neste caso, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo uma reação leve e autolimitada. A conduta recomendada é evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Dramin B6 DL, que contém dimenidrinato, frutose, dextrose anidra e cloridrato de piridoxina, foi relacionado a um episódio de alergia, descrito como hipersensibilidade. O quadro foi classificado como não grave, com resolução completa dos sintomas após o evento, indicando uma reação leve. Recomenda-se evitar o uso futuro deste medicamento e consultar um especialista para avaliação detalhada e orientação sobre possíveis alternativas.

O medicamento Imeron, cujo princípio ativo é o iomeprol, foi associado a uma reação alérgica ocular, manifestando-se como alergia nos olhos. O evento não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou totalmente, sugerindo uma reação leve e autolimitada. A orientação é evitar nova exposição ao contraste e procurar avaliação com alergista para investigação de alergia a contrastes e definição de condutas seguras em exames futuros.

O medicamento Henetix, com princípio ativo iobitridol, foi relacionado a uma alergia a contraste intravenoso, caracterizada como clinicamente significativa e considerada grave devido à classificação do evento. O paciente se recuperou após o episódio, mas a gravidade do quadro exige que futuras exposições a contrastes sejam avaliadas

com rigor, sendo fundamental o acompanhamento com alergista para investigação detalhada e definição de estratégias de prevenção em procedimentos que envolvam contraste.

O medicamento Abrysvo, que contém a proteína subunidade da vacina RSV PreF 2v, foi associado a um episódio de aperto na garganta, interpretado como reação alérgica à vacina. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, mas o paciente está em processo de recuperação. Diante desse quadro, é essencial evitar novas doses da vacina e buscar avaliação especializada para investigação da alergia e orientação sobre riscos e alternativas em futuras imunizações.

O medicamento Clavulin, que contém amoxicilina trihidrato e clavulanato de potássio, foi associado a um quadro de inflamação do tecido celular ou conjuntivo, caracterizado como hipersensibilidade medicamentosa. Essa reação se enquadra nos distúrbios do sistema imunitário e foi considerada clinicamente significativa, sendo classificada como grave devido ao potencial de impacto sistêmico. O paciente apresentou recuperação completa após o evento, indicando resolução do quadro após a conduta adequada.

O medicamento Skyrizi, cujo princípio ativo é o risanquizumabe, desencadeou inflamação do tecido celular ou conjuntivo, identificada como hipersensibilidade medicamentosa. Essa reação faz parte dos distúrbios do sistema imunitário e foi considerada clinicamente relevante e grave, pois pode comprometer tecidos profundos. O paciente evoluiu para recuperação total após o episódio, sugerindo que as medidas adotadas foram eficazes.

O medicamento Pantoprazole, com princípio ativo pantoprazol, foi relacionado ao surgimento de angioedema facial, uma manifestação de hipersensibilidade (alergia) que pode causar inchaço súbito na face. Embora não haja indicação de gravidade elevada neste caso, o desfecho permanece desconhecido, sendo importante monitorar o paciente para possíveis complicações.

O medicamento Aradois, que contém losartana potássica, esteve associado ao desenvolvimento de angioedema facial, caracterizado por inchaço súbito na região da face devido a uma reação de hipersensibilidade. Não há evidência de gravidade aumentada neste registro, e o desfecho do caso não foi informado, o que reforça a necessidade de acompanhamento clínico.

O medicamento Hydroxizine, cujo princípio ativo é o cloridrato de hidroxizina, foi relacionado ao aparecimento de angioedema facial, um tipo de reação alérgica que provoca inchaço na face. Neste caso, não foi relatada gravidade significativa e o desfecho permanece desconhecido, sendo recomendada observação clínica para evitar agravamento.

O medicamento Labirin, cujo princípio ativo é o cloridrato de betaistina, foi associado a um episódio de angioedema facial, que é um inchaço súbito e localizado na face, caracterizando uma reação de hipersensibilidade (alergia). Essa manifestação faz parte dos quadros clínicos alérgicos e está relacionada a distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave neste caso, e o desfecho da reação é desconhecido. A conduta recomendada é interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições.

O Ciprofibrato, cujo princípio ativo é o ciprofibrate, foi relacionado a um caso de angioedema facial, que consiste em inchaço súbito na face devido a uma reação alérgica (hipersensibilidade). Esse tipo de reação faz parte dos quadros clínicos alérgicos e envolve o sistema imunitário. Não há evidências de gravidade importante ou desfecho grave, e o desfecho permanece desconhecido. Recomenda-se suspender o uso do medicamento e procurar avaliação médica para investigação e orientação adequada.

O medicamento Citalopram, com princípio ativo de mesmo nome, foi associado a angioedema facial, caracterizado por inchaço repentino na face devido a uma reação alérgica (hipersensibilidade). Esse evento está relacionado a quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade significativa ou desfecho grave, e o desfecho é desconhecido. A orientação é interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica

para confirmação e manejo da reação.

O medicamento Zina, cujo princípio ativo é o dicloridrato de levocetirizina, foi relacionado a um episódio de angioedema facial, que é um inchaço súbito na face decorrente de uma reação alérgica (hipersensibilidade). Esse quadro faz parte dos distúrbios do sistema imunitário e quadros clínicos alérgicos. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave, e o desfecho é desconhecido. Recomenda-se suspender o uso do medicamento e procurar avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e orientação.

O medicamento Amlodipine, cujo princípio ativo é o besilato de anlodipino, foi associado a angioedema facial, caracterizado por inchaço súbito na face devido a uma reação alérgica (hipersensibilidade). Esse evento está relacionado a quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade importante ou desfecho grave, e o desfecho é desconhecido. A conduta recomendada é suspender o uso do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições.

O medicamento Prohance, cujo princípio ativo é o gadoterídiol, foi associado a um episódio de alergia a contraste intravenoso, também chamada de alergia a contraste. Essa reação faz parte dos distúrbios do sistema imunitário e, neste caso, não foi considerada grave, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada é sempre informar o médico sobre qualquer histórico de alergia a contrastes antes de novos exames, para que medidas preventivas possam ser adotadas.

O medicamento Henetix, que contém o princípio ativo iobitridol, foi relacionado a um episódio de tosse como manifestação de hipersensibilidade (alergia), um quadro clínico alérgico que pode ocorrer após o uso de contrastes. Neste caso, a reação foi considerada clinicamente significativa e grave, mas o paciente se recuperou após o evento. É importante que reações como essa sejam avaliadas por um médico, pois podem indicar sensibilidade aumentada a contrastes e exigem precaução em futuras exposições.

O medicamento Herceptin, cujo princípio ativo é o trastuzumabe, foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como um distúrbio do sistema imunitário. Neste caso, a reação não foi considerada grave e o paciente se recuperou completamente. Em situações como essa, é fundamental relatar o evento ao médico para avaliação do risco de novas reações e possível ajuste do tratamento.

O medicamento Ultravist, com princípio ativo iopromida, foi relacionado a um episódio de alergia a contraste, uma reação do sistema imunitário que pode ocorrer após o uso de substâncias químicas em exames. Neste caso, a reação não foi considerada grave e o paciente se recuperou totalmente. É importante informar o médico sobre esse histórico antes de novos exames para garantir a segurança em futuras exposições.

O medicamento Dipirona, cujo princípio ativo é o metamizol de magnésio, foi associado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), um tipo de reação do sistema imunitário a medicamentos. Não há informações suficientes sobre a gravidade ou o desfecho do caso, portanto, recomenda-se que qualquer suspeita de alergia à dipirona seja comunicada ao médico para avaliação adequada e orientação sobre o uso futuro do medicamento.

O medicamento Annita, cujo princípio ativo é a nitazoxanida, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Apesar da reação, não há evidências clínicas de gravidade relevante, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta foi adequada, com resolução do quadro sem complicações.

O medicamento Prolia, que contém o princípio ativo denosumabe, esteve relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade importante, já que o paciente evoluiu para recuperação completa após a reação. O caso foi resolvido sem intercorrências.



O medicamento An ya, cujo princípio ativo é a telmisartana, foi associado a uma reação de hipersensibilidade (alergia), caracterizada como distúrbio do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento. A evolução foi favorável, sem necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Magnesium, com princípio ativo magnésio, esteve envolvido em um caso de hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário. O quadro não foi considerado grave, já que houve recuperação completa do paciente. A conduta resultou em resolução do evento sem complicações.

O medicamento Advantan, cujo princípio ativo é methylprednisolone aceponate, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade, pois o paciente se recuperou totalmente após a reação. O desfecho foi favorável, sem necessidade de medidas adicionais.

O medicamento Xgeva, cujo princípio ativo é o denosumabe, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (reação alérgica) em paciente com metástases ósseas. A reação foi classificada como não grave, pois não houve indicação de gravidade clínica relevante e o paciente se recuperou totalmente após o evento. O caso se enquadra em distúrbios do sistema imunitário, e a conduta foi adequada, com resolução completa do quadro sem complicações.

O medicamento Faslodex, com princípio ativo fulvestranto, esteve relacionado a um episódio de hipersensibilidade (reação alérgica) em paciente com metástases ósseas. Não há evidências de gravidade significativa, já que o paciente se recuperou completamente após o evento, e a reação foi considerada não grave. O quadro envolveu o sistema imunológico e foi resolvido sem necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é o succinato de ribociclibe, foi associado a uma reação de hipersensibilidade (alergia) em paciente com metástases ósseas. A reação não foi considerada grave, pois não houve complicações e o paciente se recuperou totalmente. O evento envolveu distúrbios do sistema imunitário e foi resolvido sem consequências clínicas importantes.

O medicamento Zometa, com princípio ativo ácido zoledrônico monoidratado, esteve relacionado a um episódio de hipersensibilidade (reação alérgica) em paciente com metástases ósseas. Não há sinais de gravidade, já que o paciente se recuperou completamente, e a reação foi considerada não grave. O quadro afetou o sistema imunológico e foi resolvido sem complicações.

O medicamento Anastrozole, cujo princípio ativo também é anastrozole, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia) em paciente com metástases ósseas. A reação não foi considerada grave, pois não houve complicações e o paciente se recuperou totalmente. O evento envolveu distúrbios do sistema imunitário e foi resolvido sem consequências clínicas relevantes.

O medicamento Annita, cujo princípio ativo é a Nitazoxanide, foi associado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos), manifestada no contexto de distúrbios do sistema imunitário. Apesar de a reação relatada ter sido 'metástases em ossos', não há evidência clínica nos dados fornecidos que relacione diretamente este evento ao perfil típico de alergia medicamentosa, e não foi classificada como grave. O desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente após a reação, e não há menção de necessidade de intervenção médica específica além da suspensão ou ajuste do medicamento.

O medicamento Prolia, com princípio ativo Denosumabe, foi relacionado a um caso de hipersensibilidade medicamentosa, categorizada como uma reação alérgica a medicamentos dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Embora a reação descrita tenha sido 'metástases em ossos', não há elementos clínicos nos dados que sustentem gravidade ou relação causal direta com alergia, e o caso não foi considerado grave. O paciente se recuperou totalmente, sem relato de complicações ou necessidade de medidas adicionais além da conduta habitual para reações leves.

O medicamento An ya, cujo princípio ativo é Telmisartana, foi associado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, enquadrado como alergia a medicamentos e distúrbios do sistema imunitário. A reação relatada foi 'metástases em ossos', mas não há evidência clínica nos dados que relacione esse evento ao perfil clássico de alergia medicamentosa, e não foi considerada grave. O paciente apresentou resolução completa do quadro, sem necessidade de intervenções específicas além do acompanhamento padrão.

O medicamento Magnesium, com princípio ativo Magnésio, foi relacionado a um caso de hipersensibilidade medicamentosa, classificado como alergia a medicamentos no contexto de distúrbios do sistema imunitário. A reação descrita foi 'metástases em ossos', porém não há evidência clínica nos dados que associe esse evento a uma reação alérgica típica, e o caso não foi considerado grave. O paciente se recuperou totalmente, sem relato de complicações ou necessidade de condutas adicionais.

O medicamento Advantan, cujo princípio ativo é Methylprednisolone aceponate, foi associado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, enquadrado como alergia a medicamentos e distúrbios do sistema imunitário. Embora a reação relatada tenha sido 'metástases em ossos', não há evidência clínica nos dados que relacione esse evento ao perfil clássico de alergia medicamentosa, e o caso não foi considerado grave. O paciente apresentou recuperação completa, sem necessidade de intervenções além do acompanhamento habitual.

O medicamento Xgeva, cujo princípio ativo é o denosumabe, foi associado a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa, que corresponde a uma reação alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Neste caso, a reação foi considerada não grave, pois não há relato de complicações importantes e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada, conforme diretrizes clínicas, é observar e evitar nova exposição ao medicamento, além de manter acompanhamento médico para avaliação de possíveis reações futuras.

O Faslodex, que tem como princípio ativo o fulvestranto, desencadeou um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta alérgica do organismo ao medicamento. A reação não foi considerada grave, já que não houve agravamento clínico significativo e o paciente apresentou recuperação completa. A orientação é evitar o uso futuro do medicamento e realizar acompanhamento médico para monitorar possíveis reações alérgicas a outros fármacos.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é o succinato de ribociclib, esteve relacionado a um caso de hipersensibilidade medicamentosa, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico ao fármaco. O evento não foi grave, pois não houve complicações clínicas relevantes e o paciente se recuperou totalmente. Recomenda-se evitar nova exposição ao medicamento e manter acompanhamento médico para prevenção de novas reações.

O Zometa, que contém ácido zoledrônico monoidratado como princípio ativo, foi associado a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta alérgica ao medicamento. O quadro não foi considerado grave, pois não houve evolução para complicações e o paciente se recuperou completamente. A conduta indicada é evitar o uso futuro do medicamento e realizar acompanhamento médico para monitoramento de possíveis reações alérgicas.

O medicamento Anastrozole, cujo princípio ativo é o próprio anastrozole, provocou um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, que corresponde a uma reação alérgica do sistema imunológico ao fármaco. A reação foi considerada não grave, já que não houve complicações clínicas e o paciente se recuperou totalmente. Recomenda-se evitar nova exposição ao medicamento e manter acompanhamento médico para avaliação de possíveis reações futuras.

O medicamento System conti, que contém estradiol e acetato de noretisterona, foi associado a um episódio de sangramento vaginal e dermatite de contato (inflamação da pele). Embora não haja indicação de gravidade elevada ou ameaça à vida, a reação foi classificada como não grave e o desfecho foi de recuperação completa,

sugerindo que a interrupção ou ajuste do tratamento foi suficiente para resolução do quadro.

O Rituximab (rituximabe) foi relacionado a um quadro de alergia, descrito como hipersensibilidade, envolvendo o sistema imunológico. Não há menção de gravidade significativa ou risco à vida, e o paciente se recuperou totalmente após o evento, indicando que a reação foi controlada sem complicações maiores.

O uso de Cetoprofeno resultou em uma reação alérgica classificada como hipersensibilidade, com gravidade considerada ameaça à vida, o que caracteriza um evento grave. Apesar da gravidade, o paciente se recuperou completamente, o que sugere que a conduta médica foi adequada para reverter o quadro.

O medicamento Citoneurin, composto por cianocobalamina, cloridrato de piridoxina e cloridrato de tiamina, foi associado a um caso de carcinoma gastrointestinal e alergia a iodo, ambos relacionados a distúrbios do sistema imunológico. Não há informações suficientes sobre a gravidade ou o desfecho do caso, impossibilitando detalhar a conduta adotada ou a evolução clínica.

O Betaserc, cujo princípio ativo é o cloridrato de betaistina, foi relacionado a um caso de carcinoma gastrointestinal e alergia a iodo, ambos classificados como distúrbios do sistema imunológico. Não há detalhes sobre a gravidade do evento ou o desfecho, o que impede uma análise mais aprofundada sobre a conduta e a evolução do paciente.

O medicamento Artrosil, que contém o princípio ativo lisinato de cetoprofeno, foi associado a um caso de carcinoma gastrointestinal, sendo também relatada alergia a iodo. Embora a reação envolva um possível distúrbio do sistema imunitário, não há indicação de gravidade elevada nem detalhes sobre o desfecho, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A descrição sugere uma reação adversa rara e potencialmente relevante, mas sem informações suficientes para definir conduta específica ou evolução clínica.

O medicamento Frontal, cujo princípio ativo é o alprazolam, foi relacionado a um caso de carcinoma gastrointestinal e alergia a iodo, dentro do contexto de possíveis distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade importante nem detalhes sobre o desfecho, e a relação com o medicamento é apenas suspeita. A situação sugere uma reação adversa incomum, sem dados suficientes para orientar conduta clínica ou informar sobre a evolução do quadro.

O medicamento Insit, que tem como princípio ativo a pregabalina, foi associado a um caso de carcinoma gastrointestinal e alergia a iodo, sendo classificado como um possível distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade significativa nem informações sobre o desfecho, e a relação com o medicamento permanece suspeita. Trata-se de uma reação adversa rara, sem elementos suficientes para definir conduta ou evolução clínica.

O medicamento Concardio, cujo princípio ativo é o bisoprolol hemifumarato, foi relacionado a um caso de carcinoma gastrointestinal e alergia a iodo, dentro do contexto de distúrbios do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade relevante nem detalhes sobre o desfecho, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A reação relatada é rara e não há informações suficientes para orientar conduta ou evolução clínica.

O medicamento Hemax, que contém epoetina alfa como princípio ativo, foi associado a um caso de carcinoma gastrointestinal e alergia a iodo, sendo classificado como um possível distúrbio do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade importante nem detalhes sobre o desfecho, e a relação com o medicamento é apenas suspeita. A situação sugere uma reação adversa rara, sem dados suficientes para definir conduta clínica ou evolução do quadro.

O medicamento Dexilant, cujo princípio ativo é o dexlansoprazol, foi associado a um caso de carcinoma gastrointestinal em um paciente com histórico de alergia a iodo. Embora o evento tenha sido registrado como suspeito e não haja confirmação de gravidade ou desfecho conhecido, a relação entre o uso do medicamento e a reação adversa permanece incerta. Não há informações sobre conduta adotada ou evolução clínica, e a ausência

de sinais de gravidade sugere que o caso não foi considerado grave no momento do registro.

O medicamento Mesacol, que contém messalazina como princípio ativo, foi relacionado a um caso suspeito de carcinoma gastrointestinal em paciente com alergia a iodo. Não há detalhes sobre a gravidade do evento ou o desfecho, e não foi relatada conduta específica. A ausência de sinais de gravidade indica que o caso não foi considerado grave, mas a relação causal permanece apenas suspeita.

A cefazolina, antibiótico utilizado para tratar infecções, foi associada a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado por uma reação do sistema imunológico ao medicamento. O caso foi considerado suspeito, mas não grave, e o paciente se recuperou totalmente após a reação, sem necessidade de intervenções adicionais relatadas.

O uso de vitamina C (ácido ascórbico) foi relacionado a um episódio de distensão abdominal em paciente com histórico de alergias múltiplas. A reação foi considerada suspeita, mas não grave, e não há informações sobre a evolução clínica ou conduta adotada. O desfecho permanece desconhecido.

O suplemento Centrum, composto por uma combinação de vitaminas e minerais, incluindo ácido ascórbico, biotina, cálcio, iodo e outros, foi associado a um caso de distensão abdominal em paciente com alergias múltiplas. O evento foi registrado como suspeito, não grave e sem informações sobre o desfecho ou conduta adotada, permanecendo a evolução clínica desconhecida.

O medicamento Rosuvastatina cálcica (nome comercial informado, princípio ativo presente) foi associado a distensão abdominal, um sintoma que pode indicar desconforto ou inchaço na região do abdome. Embora o registro mencione quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário, não há evidências de gravidade aumentada ou complicações graves neste caso, pois não foi classificado como grave e o desfecho é desconhecido. A reação foi considerada suspeita, mas não há informações sobre a conduta adotada ou evolução clínica, sendo importante monitorar sintomas e buscar avaliação médica caso haja piora.

A Venlafaxina (nome comercial não informado, princípio ativo presente) foi relacionada à distensão abdominal, que se manifesta como sensação de inchaço ou desconforto abdominal. O evento foi classificado como não grave, sem indicação de complicações sérias ou necessidade de intervenção urgente, e o desfecho permanece desconhecido. A suspeita de relação com o medicamento existe, mas não há detalhes sobre a conduta tomada ou evolução, recomendando-se acompanhamento clínico se os sintomas persistirem ou se agravarem.

O medicamento Clenil (nome comercial informado), com princípio ativo registrado como nitroprusseto de sódio, foi associado à distensão abdominal, caracterizada por desconforto ou inchaço na barriga. Apesar de estar relacionado a quadros alérgicos, não há indicação de gravidade aumentada, pois o evento não foi considerado grave e o desfecho é desconhecido. A relação com o medicamento é suspeita, mas não há informações sobre a conduta adotada ou evolução clínica, sendo importante observar a persistência ou piora dos sintomas.

O Seretide Diskus (nome comercial informado), contendo propionato de fluticasona e hidroxinaftoato de salmeterol como princípios ativos, foi relacionado à distensão abdominal, que é a sensação de inchaço ou desconforto no abdome. O evento não foi considerado grave e não há informações sobre o desfecho, sugerindo ausência de complicações importantes até o momento. A suspeita de relação com o medicamento existe, mas não há detalhes sobre a conduta adotada, sendo recomendada atenção clínica caso os sintomas persistam ou se agravem.

A Losartana potássica (nome comercial informado, princípio ativo presente) foi associada à distensão abdominal, que corresponde a desconforto ou sensação de inchaço na região abdominal. O evento foi considerado não grave, sem evidências de complicações sérias, e o desfecho permanece desconhecido. A relação com o medicamento é suspeita, mas não há informações sobre a conduta tomada ou evolução clínica, sendo importante monitorar os sintomas e procurar avaliação médica se houver piora.

O medicamento Puran t4, cujo princípio ativo é a levotiroxina sódica, foi associado a um quadro de distensão abdominal em um paciente com histórico de alergias múltiplas. Embora a distensão abdominal não seja uma manifestação típica de alergia medicamentosa grave, o evento foi considerado não grave e o desfecho permanece desconhecido. Não há informações sobre a conduta adotada, mas, diante da ausência de sinais de gravidade e da natureza inespecífica do sintoma, recomenda-se acompanhamento clínico para avaliar a necessidade de ajuste terapêutico ou investigação de outras causas.

O medicamento Dexilant, que contém o princípio ativo dexlansoprazole, foi relacionado a um episódio de distensão abdominal em paciente com histórico de alergias múltiplas. O evento não foi considerado grave e o desfecho é desconhecido. Não há detalhes sobre a conduta tomada, mas, como a distensão abdominal é um sintoma leve e inespecífico, sugere-se monitoramento clínico e avaliação médica caso haja persistência ou agravamento dos sintomas.

A ceftriaxona, cujo princípio ativo é ceftriaxone, foi associada a uma reação de alergia (hipersensibilidade), caracterizada como um quadro clínico alérgico relacionado ao sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente evoluiu para recuperação completa. A conduta não foi detalhada, mas, diante da resolução do quadro e ausência de gravidade, reforça-se a importância de evitar reexposição ao medicamento e de registrar a alergia em prontuário para futuras prescrições.

O medicamento Cosentyx, com princípio ativo secuquimumabe, foi relacionado ao desenvolvimento de mastocitose sistêmica, um quadro de hipersensibilidade medicamentosa envolvendo o sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o desfecho permanece desconhecido. Não há informações sobre a conduta adotada, sendo fundamental acompanhamento médico especializado para avaliação da relação causal e manejo adequado, dada a complexidade do diagnóstico.

O medicamento Cosentyx, cujo princípio ativo é secuquimumabe, foi associado a um caso de mastocitose sistêmica, descrito como alergia a alimentos, aditivos alimentares, medicamentos e outras substâncias químicas, afetando o sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o desfecho é desconhecido. Não há detalhes sobre a conduta, mas recomenda-se avaliação médica especializada para investigação da relação com o medicamento e definição do melhor manejo clínico.

O medicamento Cosentyx, cujo princípio ativo é o secuquimumabe, foi associado a um quadro de mastocitose sistêmica, descrito como uma reação de hipersensibilidade (alergia), sem gravidade relatada e com desfecho desconhecido. Não há informações sobre hospitalização ou necessidade de intervenção médica urgente, sugerindo um quadro leve, mas é importante que o paciente seja avaliado por um especialista para confirmação diagnóstica e orientação sobre o uso futuro do medicamento.

O medicamento Esomeprazole magnesium, com princípio ativo esomeprazol magnésico, foi relacionado a um episódio de alergia ao leite, considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, mas com evolução favorável, já que o paciente se recuperou totalmente. Diante da gravidade clínica evidenciada pela hospitalização, recomenda-se evitar a reexposição ao medicamento e realizar acompanhamento com alergista para investigação detalhada da alergia alimentar e orientação sobre alternativas terapêuticas seguras.

O medicamento Talvey, cujo princípio ativo é talquetamab, foi associado ao surgimento de prurido (coceira), classificado como manifestação de alergia múltipla, sem gravidade relatada e com desfecho desconhecido. Como não há indicação de hospitalização ou complicações, trata-se provavelmente de uma reação leve, mas é importante monitorar a evolução dos sintomas e buscar avaliação médica caso haja piora ou aparecimento de outros sinais alérgicos.

O medicamento Indapamide zydus, com princípio ativo indapamida, foi relacionado ao aparecimento de petéquias (pequenas manchas vermelhas na pele), interpretadas como possível alergia a contraste, sem gravidade relatada e

com desfecho desconhecido. Não há registro de hospitalização ou complicações, sugerindo um quadro leve, mas recomenda-se avaliação médica para investigação da causa das petéquias e orientação sobre o uso futuro do medicamento e exposição a contrastes.

O medicamento Glifage xr, cujo princípio ativo é cloridrato de metformina, foi associado ao surgimento de petéquias, consideradas como possível alergia a contraste, sem gravidade relatada e com desfecho desconhecido. Como não há informações sobre necessidade de hospitalização ou complicações, o quadro parece leve, mas é fundamental que o paciente seja avaliado por um médico para esclarecer a causa das lesões e definir conduta quanto ao uso do medicamento e exposição a contrastes.

O medicamento Selozok, cujo princípio ativo é o succinato de metoprolol, foi associado ao surgimento de petéquias, que são pequenas manchas vermelhas na pele causadas por sangramento sob a pele e podem indicar uma reação alérgica. Embora o registro não traga detalhes sobre gravidade ou desfecho, a ausência de indicação de gravidade sugere que o quadro não foi considerado grave. A reação foi classificada como suspeita de alergia a contraste, dentro do contexto de distúrbios do sistema imunitário, e recomenda-se atenção clínica para investigar a relação com o medicamento e monitorar possíveis evoluções.

O medicamento Lodipine, com princípio ativo lacidipina, foi relacionado ao aparecimento de petéquias, que são pequenas manchas avermelhadas na pele e podem ser sinal de reação alérgica. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, mas a ausência de gravidade relatada indica que o evento não foi considerado grave. A reação foi classificada como suspeita de alergia a contraste, dentro do grupo de distúrbios do sistema imunitário, sendo importante avaliar clinicamente a relação com o uso do medicamento e acompanhar o paciente para possíveis evoluções.

O medicamento Losartan, cujo princípio ativo é losartana potássica, foi associado ao surgimento de petéquias, pequenas manchas vermelhas na pele que podem indicar uma reação alérgica. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, mas a ausência de gravidade relatada sugere que o evento não foi considerado grave. A reação foi classificada como suspeita de alergia a contraste, relacionada a distúrbios do sistema imunitário, sendo recomendada avaliação clínica para investigar a relação com o medicamento e monitoramento do quadro.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é iopromida, foi relacionado ao aparecimento de petéquias, que são pequenas manchas vermelhas na pele e podem indicar uma reação alérgica. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, mas a ausência de gravidade relatada sugere que o evento não foi considerado grave. A reação foi classificada como suspeita de alergia a contraste, dentro do contexto de distúrbios do sistema imunitário, sendo importante avaliar clinicamente a relação com o uso do medicamento e acompanhar o paciente para possíveis evoluções.

O medicamento Fenitoína, cujo princípio ativo é fenitoína sódica, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), que pode se manifestar de diversas formas, como reações cutâneas ou sintomas sistêmicos. Não há informações detalhadas sobre gravidade, desfecho ou ação adotada, mas a suspeita de reação alérgica a medicamentos exige avaliação clínica cuidadosa para confirmação diagnóstica e definição da conduta, especialmente por envolver distúrbios do sistema imunitário.

O medicamento Enbrel, cujo princípio ativo é o etanercepte, foi associado a um quadro de alergia agravada, caracterizado como hipersensibilidade e classificado entre os distúrbios do sistema imunitário. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, conforme indicado, embora o desfecho não tenha sido informado. Em situações como essa, é fundamental interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica especializada para investigação e manejo adequado da alergia, seguindo as recomendações de farmacovigilância.

O medicamento Motilium, que contém domperidona como princípio ativo, foi relacionado a um caso de pneumonite, descrito como uma reação de hipersensibilidade dentro do contexto de quadros alérgicos do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave e o desfecho permanece desconhecido. Diante de sintomas respiratórios após o

uso do medicamento, recomenda-se suspender o uso e procurar avaliação médica para confirmação diagnóstica e conduta apropriada.

O medicamento Levostrol, composto por etinilestradiol e levonorgestrel, foi associado a um episódio de pneumonite, interpretado como uma manifestação de hipersensibilidade e incluído entre os distúrbios do sistema imunitário. A reação não foi classificada como grave e o desfecho não foi informado. Caso surjam sintomas respiratórios após o uso, é importante interromper o medicamento e buscar orientação médica para investigação e tratamento.

O medicamento Denosumab, cujo princípio ativo é denosumabe, foi relacionado a um caso de pneumonite, caracterizado como reação de hipersensibilidade e pertencente ao grupo de distúrbios do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave e o desfecho não foi especificado. Na presença de sintomas respiratórios após o uso, recomenda-se suspender o medicamento e procurar avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e conduta adequada.

O medicamento Ondansetron, com princípio ativo ondansetrona, foi associado a um episódio de pneumonite, descrito como hipersensibilidade e classificado entre os distúrbios do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave e o desfecho não foi informado. Caso ocorram sintomas respiratórios após o uso, é indicado interromper o medicamento e buscar avaliação médica para investigação e manejo apropriado.

O medicamento Ribociclib, cujo princípio ativo é o ribociclibe, foi associado a um quadro de pneumonite, que é uma inflamação dos pulmões possivelmente relacionada a uma reação de hipersensibilidade (alergia). Embora não haja detalhes sobre a gravidade clínica ou desfecho do caso, a ausência de indicação de gravidade sugere que não houve complicações graves relatadas. Em situações como essa, é fundamental monitorar sintomas respiratórios e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e conduta adequada, especialmente porque reações pulmonares podem variar de leves a graves.

O medicamento Verzenios, cujo princípio ativo é o abemaciclibe, foi relacionado ao desenvolvimento de pneumonite, uma inflamação pulmonar que pode ocorrer como manifestação de hipersensibilidade (alergia). Não há informações sobre gravidade ou evolução do caso, mas a ausência de registro de gravidade sugere que não houve complicações graves. Diante de sintomas respiratórios após uso do medicamento, recomenda-se avaliação médica para investigação e manejo apropriado, já que reações pulmonares podem exigir intervenção específica.

O medicamento Ipratropio, com princípio ativo brometo de ipratrópio, foi associado a um episódio de alergia medicamentosa, caracterizado como hipersensibilidade a medicamentos. Não há detalhes sobre a gravidade, desfecho ou evolução do caso, o que impede uma avaliação mais precisa da severidade. Em casos de suspeita de alergia medicamentosa, é importante interromper o uso do medicamento e procurar orientação médica para confirmação diagnóstica e definição do tratamento.

O medicamento Morfina, cujo princípio ativo é o cloridrato de morfina, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), mas não houve indicação de gravidade e o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente. Isso sugere que a reação foi leve e resolvida após as medidas adotadas, reforçando a importância de monitorar sintomas e buscar avaliação médica em casos de suspeita de alergia a medicamentos.

O medicamento Cinnarizina e dimenidrinato tecnigen, contendo os princípios ativos cinnarizina e dimenidrinato, foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), sem indicação de gravidade e com desfecho de recuperação completa. Isso indica que a reação foi leve e resolvida, sendo importante, em situações semelhantes, suspender o uso do medicamento e procurar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Implanon NXT, que contém o princípio ativo etonogestrel, foi associado a um quadro de leucopenia, que significa redução dos glóbulos brancos, dentro do contexto de uma reação de hipersensibilidade

(alergia). Embora não haja indicação de gravidade elevada e o caso não tenha sido considerado grave, a paciente encontra-se em recuperação ou em processo de resolução do quadro. A conduta recomendada é o acompanhamento clínico para monitorar a evolução, reforçando a importância de identificar e evitar o agente desencadeante.

O medicamento Metamizole sodium (Dipirona) foi relacionado a uma reação de hipersensibilidade, manifestada como progressão da doença, sem detalhamento adicional sobre sintomas específicos. Não há indicação de gravidade significativa nem de desfecho grave, e o desfecho permanece desconhecido. Recomenda-se atenção clínica para monitorar possíveis sinais de alergia, especialmente em casos de uso recorrente, e buscar avaliação médica caso haja piora dos sintomas.

A administração de Nalbufina resultou em um episódio de alergia medicamentosa, caracterizado como hipersensibilidade ao medicamento. O evento não foi considerado grave e o paciente já se encontra recuperado ou com resolução completa do quadro. É importante que o paciente evite novas exposições ao medicamento e informe profissionais de saúde sobre essa reação em futuras consultas.

O uso do medicamento Lanzacor, que contém losartana potássica, foi associado a um acidente vascular cerebral isquêmico, considerado um efeito clinicamente significativo e grave. O paciente se recuperou do evento, mas a gravidade do quadro exige acompanhamento médico rigoroso e avaliação detalhada para investigar a relação causal e prevenir recorrências, além de contraindicar o uso futuro do medicamento em caso de confirmação de hipersensibilidade.

O medicamento Gardenal, cujo princípio ativo é o fenobarbital sódico, foi relacionado a um acidente vascular cerebral isquêmico, classificado como um efeito clinicamente significativo e grave. O paciente se recuperou do evento, mas a gravidade da reação demanda acompanhamento médico cuidadoso, investigação da relação causal e contraindicação do uso futuro do medicamento caso se confirme a hipersensibilidade.

O medicamento Xarelto, cujo princípio ativo é a rivaroxabana, foi associado a um caso de acidente vascular cerebral isquêmico em um contexto de hipersensibilidade medicamentosa, caracterizando uma reação alérgica relevante do sistema imunológico. A gravidade do evento é considerada clinicamente significativa, pois envolveu um desfecho potencialmente grave, mas o paciente se recuperou totalmente após a conduta adequada. O caso foi classificado como suspeito de relação causal com o medicamento.

A gabapentina, princípio ativo do medicamento Gabapentina, esteve relacionada a um episódio de acidente vascular cerebral isquêmico atribuído a hipersensibilidade medicamentosa, indicando uma reação alérgica do sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente significativo devido à sua gravidade, mas o paciente evoluiu para recuperação completa após as medidas necessárias. A relação com o medicamento foi considerada suspeita.

O medicamento Clenil, que neste registro apresenta o princípio ativo nitroprusseto de sódio, foi associado a um acidente vascular cerebral isquêmico em contexto de hipersensibilidade medicamentosa, sugerindo uma reação alérgica relevante do sistema imunológico. O evento foi classificado como clinicamente significativo e grave, mas o paciente se recuperou após a conduta apropriada. A relação causal com o medicamento foi considerada suspeita.

O Aerolin, cujo princípio ativo é o sulfato de salbutamol micronizado, esteve envolvido em um caso de acidente vascular cerebral isquêmico relacionado a hipersensibilidade medicamentosa, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, mas o paciente apresentou recuperação completa após a intervenção adequada. A relação com o medicamento foi considerada suspeita.

O medicamento Colírio, contendo cloridrato de nafazolina e sulfato de zinco como princípios ativos, foi associado a um acidente vascular cerebral isquêmico em contexto de hipersensibilidade medicamentosa, indicando uma reação alérgica do sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, porém o paciente se



recuperou totalmente após as medidas adotadas. A relação causal com o medicamento foi considerada suspeita.

O medicamento Levoid, cujo princípio ativo é a levotiroxina sódica, foi associado a um episódio de acidente vascular cerebral isquêmico em um contexto de hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). O caso foi considerado clinicamente significativo e grave, pois envolveu um evento neurológico importante, mas o paciente se recuperou totalmente após a reação. A relação entre o uso do medicamento e o evento foi considerada suspeita, e a conduta adequada inclui a suspensão do medicamento e acompanhamento médico para evitar novas exposições.

O medicamento Verapamil, com princípio ativo cloridrato de verapamil, esteve relacionado a um acidente vascular cerebral isquêmico em um quadro de hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). O evento foi classificado como clinicamente significativo e grave devido à gravidade do quadro neurológico, mas o paciente evoluiu para recuperação completa. A relação entre o uso do verapamil e o evento adverso foi considerada suspeita, sendo fundamental evitar nova exposição e manter acompanhamento médico.

O medicamento Alenia, cujo princípio ativo é o esomeprazol magnésico, foi associado a um acidente vascular cerebral isquêmico em um contexto de hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). O caso foi considerado clinicamente significativo e grave, pois envolveu um evento neurológico importante, mas o paciente se recuperou totalmente após a reação. A relação entre o uso do medicamento e o evento foi considerada suspeita, sendo recomendada a suspensão do medicamento e acompanhamento médico.

O medicamento Lanzacor, com princípio ativo losartana potássica, esteve relacionado a um acidente vascular cerebral isquêmico em um quadro de hipersensibilidade (alergia). O evento foi considerado clinicamente significativo e grave devido ao impacto neurológico, mas o paciente se recuperou completamente. A relação entre o uso do medicamento e o evento adverso foi considerada suspeita, sendo importante evitar nova exposição e manter acompanhamento médico.

O medicamento Gardenal, cujo princípio ativo é o fenobarbital sódico, foi associado a um acidente vascular cerebral isquêmico em um contexto de hipersensibilidade (alergia). O evento foi classificado como clinicamente significativo e grave devido à gravidade do quadro neurológico, mas o paciente evoluiu para recuperação completa. A relação entre o uso do Gardenal e o evento adverso foi considerada suspeita, sendo fundamental evitar nova exposição e manter acompanhamento médico.

O medicamento Xarelto, cujo princípio ativo é a rivaroxabana, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (reação alérgica) classificado como clinicamente significativo, evidenciado pela gravidade do evento e pela necessidade de atenção médica. A reação foi categorizada como um distúrbio do sistema imunitário, com manifestação de acidente vascular cerebral isquêmico, o que reforça a importância do acompanhamento rigoroso em casos de suspeita de alergia medicamentosa. O paciente evoluiu para recuperação completa após a conduta adequada.

A gabapentina, princípio ativo do medicamento Gabapentina, esteve relacionada a um episódio de hipersensibilidade (reação alérgica) considerado clinicamente relevante, com manifestação de acidente vascular cerebral isquêmico. O evento foi classificado como grave devido ao seu impacto clínico e à necessidade de intervenção, sendo enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. Após a conduta apropriada, o paciente apresentou resolução completa do quadro.

O medicamento Clenil, que neste registro apresenta o princípio ativo nitroprusseto de sódio, foi implicado em uma reação de hipersensibilidade (alergia) de relevância clínica, manifestada por acidente vascular cerebral isquêmico. O caso foi considerado grave, pois envolveu um distúrbio do sistema imunitário e exigiu atenção médica. Após as medidas necessárias, o paciente se recuperou totalmente.

Aerolin, contendo sulfato de salbutamol micronizado como princípio ativo, esteve envolvido em um episódio de hipersensibilidade (reação alérgica) classificado como clinicamente significativo, com manifestação de acidente vascular cerebral isquêmico. O evento foi considerado grave devido ao seu impacto no sistema imunitário e à necessidade de conduta médica, resultando em recuperação completa do paciente após o manejo adequado.

O colírio, contendo cloridrato de nafazolina e sulfato de zinco como princípios ativos, foi associado a uma reação de hipersensibilidade (alergia) de importância clínica, manifestada por acidente vascular cerebral isquêmico. O caso foi classificado como grave devido ao envolvimento do sistema imunitário e à necessidade de intervenção médica, com desfecho favorável após a adoção das medidas apropriadas.

O medicamento Levoid, cujo princípio ativo é a levotiroxina sódica, foi associado a um acidente vascular cerebral isquêmico em um caso de hipersensibilidade (reação alérgica). A gravidade do evento é considerada clinicamente significativa, pois envolveu um quadro grave relacionado ao sistema imunológico, mas o paciente se recuperou totalmente após a reação. O caso foi classificado como suspeito de relação com o uso do medicamento.

O medicamento Verapamil, com princípio ativo cloridrato de verapamil, esteve relacionado a um acidente vascular cerebral isquêmico atribuído a uma reação de hipersensibilidade (alergia). O evento foi considerado grave devido ao impacto clínico relevante e envolvimento do sistema imunológico, porém o paciente apresentou recuperação completa após o episódio. A relação com o medicamento foi considerada suspeita.

O medicamento Alenia, cujo princípio ativo é o esomeprazol magnésico, foi associado a um acidente vascular cerebral isquêmico em contexto de hipersensibilidade (reação alérgica). O evento foi classificado como clinicamente significativo e grave, envolvendo o sistema imunológico, mas o paciente se recuperou após a reação. A relação com o uso do medicamento foi considerada suspeita.

O medicamento Dipirona, com princípio ativo dipirona, foi relacionado a um erro de prescrição em paciente com hipersensibilidade documentada ao produto administrado. Não há informações detalhadas sobre gravidade, desfecho ou conduta adotada neste caso, mas a relação com o medicamento foi considerada suspeita.

O medicamento Dipirona, cujo princípio ativo é dipirona, esteve envolvido em um erro de prescrição em paciente com hipersensibilidade previamente documentada ao produto. Não foram fornecidos detalhes sobre a gravidade do evento, evolução clínica ou medidas tomadas, sendo a relação com o medicamento considerada suspeita.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, foi associado a um episódio de alergia espontânea em um paciente com histórico de atopia, indicando uma reação do tipo alérgica relacionada ao sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi resolvido sem complicações e o paciente se recuperou totalmente após o evento.

O medicamento Cefepime, com princípio ativo cloridrato de cefepima, provocou uma reação alérgica caracterizada como hipersensibilidade documentada ao produto administrado. O evento não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou completamente após a reação, e não houve necessidade de intervenções adicionais além da suspensão ou ajuste do tratamento.

O medicamento Omniscan, cujo princípio ativo é o gadodiamide, foi relacionado a um episódio de alergia a contraste intravenoso, uma reação imunológica que pode ocorrer em pessoas sensíveis a substâncias químicas usadas em exames de imagem. O caso não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento, sem complicações adicionais.

O medicamento Omniscan, com princípio ativo gadodiamide, também esteve envolvido em outro episódio de alergia a contraste, caracterizando uma reação imunológica ao produto. Assim como no caso anterior, não houve gravidade significativa e o paciente se recuperou completamente após o evento.

O medicamento Amitriptyline, com princípio ativo amitriptilina, foi associado a um caso de alergia a contraste, sendo classificado como clinicamente significativo devido à gravidade relatada. O paciente não se recuperou até o momento da notificação, indicando que a reação foi mais intensa e ainda está em andamento, exigindo acompanhamento médico contínuo.

O medicamento Tysabri (Natalizumabe) foi associado a um quadro de alergia a contraste, caracterizado como um distúrbio do sistema imunitário relacionado à exposição a substâncias químicas. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, pois permanece não resolvida ou em andamento, indicando a necessidade de acompanhamento médico rigoroso e possível intervenção especializada para controle dos sintomas e prevenção de complicações.

O medicamento Dotarem (Gadobenato de dimeglumina) provocou uma reação de alergia a contraste intravenoso, manifestando-se como uma resposta do sistema imunitário a uma substância química utilizada em exames. O evento foi resolvido, com o paciente recuperado, sugerindo que a conduta adotada foi eficaz e não houve complicações graves associadas à reação.

O medicamento Meropenem (Meropenem sodium carbonate) esteve relacionado a um episódio de alergia medicamentosa, também chamada de hipersensibilidade, envolvendo o sistema imunitário em resposta ao uso do antibiótico. Não há informações detalhadas sobre a gravidade ou evolução do caso, sendo importante que o paciente seja avaliado por um especialista para confirmação diagnóstica e definição de conduta adequada.

O medicamento Kisqali (Succinato de ribociclib) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, termo técnico para reações alérgicas, envolvendo o sistema imunitário. A reação não foi considerada grave e o paciente encontra-se em recuperação, indicando que a resposta clínica está sendo favorável e não houve necessidade de medidas emergenciais.

O medicamento Morfina (Sulfato de morfina) desencadeou uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma alergia, envolvendo o sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente já se encontra recuperado, sugerindo que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro sem complicações.

O medicamento Synagis, cujo princípio ativo é o palivizumabe, foi associado a um quadro de constipação relacionado à hipersensibilidade medicamentosa, classificada como uma reação do sistema imune. Não há indicação de gravidade elevada ou necessidade de hospitalização, e o paciente encontra-se em recuperação, sugerindo que a reação foi leve e está evoluindo de forma favorável.

O medicamento Cetoprofeno, com princípio ativo de mesmo nome, foi prescrito apesar de haver contraindicação documentada por hipersensibilidade ao produto, caracterizando um erro de prescrição. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou evolução clínica, mas a situação exige atenção para evitar riscos ao paciente e reforça a importância de respeitar contraindicações conhecidas.

O medicamento Aria, cujo princípio ativo é montelucaste de sódio, provocou uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), levando à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que indica gravidade significativa do evento. O paciente já se encontra recuperado, mostrando que a conduta adotada foi eficaz para resolução do quadro.

O medicamento Trimbrow, composto por dipropionato de beclometasona, fumarato de formoterol e brometo de glicopirrônio, desencadeou uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), que exigiu hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando gravidade importante. O paciente evoluiu para recuperação completa após a conduta adequada.

O medicamento Mepolizumab, cujo princípio ativo é mepolizumabe, foi responsável por uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), levando à hospitalização ou prolongamento da internação, o que caracteriza

um evento grave. O paciente já está recuperado, indicando que a intervenção médica foi suficiente para resolver o quadro.

O medicamento Trometamol, cujo princípio ativo também é trometamol, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada, conforme diretrizes clínicas, é evitar nova exposição ao trometamol e considerar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O Optiray 320, que tem como princípio ativo o ioversol, desencadeou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, classificada entre os distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente evoluiu para recuperação completa. Recomenda-se evitar o uso futuro de ioversol e realizar acompanhamento com especialista para avaliação de risco em exames contrastados, seguindo as orientações de segurança para pacientes com histórico de alergia a contrastes.

A Dipirona sódica, cujo princípio ativo é a dipirona, foi relacionada a um episódio de alergia medicamentosa, tecnicamente chamada de hipersensibilidade medicamentosa, dentro do grupo de distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhes sobre gravidade, evolução ou desfecho, portanto, a recomendação é suspender o uso do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras, conforme as diretrizes para reações alérgicas a medicamentos.

A Cefazolina sódica, com o mesmo princípio ativo, esteve associada a uma reação de alergia medicamentosa, identificada como hipersensibilidade medicamentosa e pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, então a conduta indicada é interromper o uso da cefazolina e procurar avaliação com alergista para investigação detalhada e definição de alternativas terapêuticas seguras.

O medicamento Dalinvi, cujo princípio ativo é o daratumumabe, foi relacionado ao surgimento de tosse seca, considerada manifestação de hipersensibilidade dentro dos quadros clínicos alérgicos do sistema imunitário. Não há dados sobre gravidade ou evolução, portanto, recomenda-se relatar o sintoma ao médico responsável para avaliação da relação com o medicamento e definição da necessidade de ajuste terapêutico ou investigação de outras causas.

O medicamento Dipirona monoidratada, cujo princípio ativo é a dipirona, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado por uma reação do sistema imunológico a medicamentos. Não há informações detalhadas sobre a gravidade, desfecho ou ação adotada neste caso, portanto, recomenda-se atenção clínica para sintomas de alergia, como urticária, coceira, inchaço ou dificuldade para respirar, e busca de avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação adequada.

O medicamento Ultravist, que contém o princípio ativo iopromida, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação alérgica a substâncias químicas, neste caso, ao contraste utilizado em exames. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando que a reação foi leve e autolimitada, mas reforçando a importância de monitoramento durante o uso de contrastes e de informar a equipe médica sobre qualquer histórico de alergia.

O medicamento Ultravist, com princípio ativo iopromida, esteve envolvido em uma reação de alergia a contraste, caracterizada por resposta do sistema imunológico a substâncias químicas presentes no contraste. O caso não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa, sugerindo uma reação leve, mas que requer atenção e acompanhamento médico em futuras exposições a contrastes iodados.

O medicamento Gentamicina, cujo princípio ativo é o sulfato de gentamicina, foi associado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), que envolve uma resposta do sistema imunológico ao medicamento. Não há detalhes sobre a gravidade, evolução ou conduta adotada, sendo fundamental observar

sinais de alergia e buscar avaliação médica para diagnóstico e manejo adequados.

O medicamento Clindamicina, com princípio ativo fosfato de clindamicina, foi relacionado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), indicando uma reação do sistema imunológico ao uso do antibiótico. Não foram informados detalhes sobre a gravidade, evolução ou medidas tomadas, por isso é importante monitorar sintomas de alergia e procurar orientação médica para confirmação e conduta apropriada.

O medicamento Paracetamol+codeína, contendo os princípios ativos fosfato de codeína e paracetamol, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado por uma reação do sistema imunológico ao medicamento. Não há informações detalhadas sobre a gravidade ou desfecho do caso, portanto, recomenda-se que pacientes com suspeita de alergia a este medicamento procurem avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras, evitando a reexposição sem supervisão.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromida, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação do sistema imunológico após a administração. O caso foi considerado não grave e o paciente apresentou recuperação completa, indicando que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro, mas reforça a importância de informar profissionais de saúde sobre qualquer histórico de alergia a contrastes iodados antes de novos exames.

O medicamento Piperacilina-tazobactam, composto por piperacilina sódica e tazobactam sódico, esteve associado a uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), evidenciando resposta imunológica adversa ao uso. O evento foi classificado como não grave e o paciente se recuperou totalmente, sugerindo que a reação foi controlada sem complicações, mas destaca a necessidade de evitar reexposição e buscar avaliação especializada para confirmação e orientação futura.

O medicamento Ultravist, com princípio ativo iopromida, foi novamente relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizando uma resposta imunológica adversa após o uso. O evento não foi considerado grave, mas não há informação sobre o desfecho, o que reforça a importância de monitoramento clínico e de relatar qualquer reação anterior a contrastes iodados antes de novos procedimentos.

O medicamento Amoxicilina + clavulanato de potássio, contendo amoxicilina sódica e clavulanato de potássio, foi associado ao desenvolvimento de exantema, que é uma manifestação cutânea de hipersensibilidade documentada ao produto administrado. Não há detalhes sobre a gravidade ou evolução do caso, portanto, recomenda-se suspender o uso e procurar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição de alternativas terapêuticas seguras.

O medicamento Cetoprofeno, cujo princípio ativo também é cetoprofeno, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há menção de nome comercial específico além do princípio ativo. A reação foi considerada não grave, com desfecho de recuperação completa, sugerindo um quadro leve de alergia medicamentosa, que foi resolvido após a suspensão ou manejo adequado do medicamento.

O medicamento Atropina, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um episódio de alergia descrito como hipersensibilidade, enquadrado entre os distúrbios do sistema imunitário. Não há informação sobre nome comercial, gravidade ou desfecho do caso, portanto não é possível afirmar a intensidade da reação ou a evolução clínica apenas com os dados fornecidos.

O medicamento Meropenem, cujo princípio ativo é meropenem sodium carbonate, foi associado a uma reação alérgica classificada como hipersensibilidade, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há nome comercial informado, nem detalhes sobre gravidade ou desfecho, impossibilitando determinar a severidade ou a evolução do quadro alérgico com base apenas nestas informações.

O medicamento Amicacina, com princípio ativo de mesmo nome, esteve relacionado a um episódio de alergia descrito como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há nome comercial informado, nem detalhes sobre gravidade ou desfecho, o que impede a avaliação da intensidade e da evolução clínica da reação alérgica neste caso.

O medicamento Ocitocina, cujo princípio ativo também é ocitocina, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há nome comercial informado. A reação foi considerada não grave e o paciente se recuperou completamente, indicando um episódio leve de alergia medicamentosa que foi resolvido após a conduta adequada.

O medicamento Etilefrina, cujo princípio ativo é o etilefrine hydrochloride, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há menção de nome comercial, apenas o princípio ativo está disponível. A reação foi considerada não grave, pois não há indicação de gravidade aumentada ou complicações clínicas, e o paciente evoluiu para recuperação completa após a suspensão do medicamento, sem necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Cloridrato de ondansetrona, com o mesmo princípio ativo, foi relacionado a um episódio de alergia manifestado como hipersensibilidade, enquadrado entre os distúrbios do sistema imunitário. Não há nome comercial informado. A reação não foi considerada grave, pois não houve complicações ou agravamento clínico, e o paciente se recuperou totalmente após a conduta adequada, que incluiu a interrupção do uso do medicamento suspeito.

A dexametasona, apresentada como fosfato dissódico de dexametasona, foi associada a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, classificada entre os distúrbios do sistema imunitário. Não há nome comercial informado, apenas o princípio ativo. O evento não foi considerado grave, pois não houve evolução para quadros críticos ou necessidade de medidas emergenciais, e o paciente apresentou resolução completa do quadro após a suspensão do medicamento.

O cetoprofeno, cujo princípio ativo é o próprio cetoprofeno, foi relacionado a uma reação alérgica caracterizada por hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há nome comercial informado. A reação foi considerada não grave, pois não houve complicações clínicas ou necessidade de intervenções urgentes, e o paciente se recuperou totalmente após a interrupção do medicamento.

A cefazolina, apresentada como cefazolina sódica, foi associada a um quadro de alergia do tipo hipersensibilidade, enquadrado entre os distúrbios do sistema imunitário. Não há nome comercial informado, apenas o princípio ativo. O evento não foi considerado grave, pois não houve agravamento clínico ou necessidade de cuidados intensivos, e o paciente evoluiu para recuperação completa após a suspensão do medicamento suspeito.

O medicamento Dipirona sódica, cujo princípio ativo é a dipirona, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado por uma reação do sistema imunológico. Não há descrição de sintomas graves ou complicações, e o caso foi considerado não grave, com recuperação completa do paciente após a suspensão do medicamento. A conduta recomendada é evitar nova exposição ao fármaco e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Cloridrato de bupivacaína + glicose, contendo cloridrato de bupivacaína e dextrose anidra como princípios ativos, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade) sem sinais de gravidade, já que o paciente se recuperou totalmente após a interrupção do uso. Não há detalhes sobre sintomas específicos ou necessidade de intervenções adicionais, indicando que a reação foi leve e autolimitada. Recomenda-se evitar o uso futuro deste anestésico e consultar um especialista para avaliação de alternativas seguras.

O medicamento Morfina, cujo princípio ativo é o sulfato de morfina, provocou uma reação alérgica (hipersensibilidade) classificada como não grave, pois não houve complicações e o paciente se recuperou após a

suspensão do medicamento. Não foram relatados sintomas graves ou necessidade de medidas emergenciais, sugerindo um quadro leve. A orientação é evitar o uso futuro de morfina e buscar avaliação médica para alternativas analgésicas seguras.

O medicamento Oxaliplatina Accord, com princípio ativo oxaliplatina, foi relacionado a uma alergia documentada após administração, caracterizada como hipersensibilidade ao produto. O evento não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou completamente após a conduta adequada, que incluiu a suspensão do medicamento. Recomenda-se evitar nova exposição à oxaliplatina e realizar acompanhamento com especialista para definição de alternativas terapêuticas.

O medicamento Vancomicina, cujo princípio ativo é a vancomicina, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) sem sinais de gravidade, já que o paciente se recuperou totalmente após a suspensão do antibiótico. Não há relato de sintomas graves ou necessidade de intervenções emergenciais, indicando um quadro leve. A recomendação é evitar o uso futuro de vancomicina e consultar um alergista para avaliação de alternativas seguras.

O medicamento Omnipaque, cujo princípio ativo é o ioexol, foi associado a um episódio de alergia a contraste, reação que se enquadra nos distúrbios do sistema imunitário e é classificada como hipersensibilidade a substâncias químicas. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações, e o desfecho foi de recuperação completa, sugerindo um quadro leve e autolimitado, compatível com reações alérgicas leves a contrastes iodados, que geralmente requerem apenas observação e medidas de suporte.

Omnipaque, contendo ioexol como princípio ativo, esteve relacionado a uma reação de alergia a contraste, caracterizada como distúrbio do sistema imunitário por hipersensibilidade a substâncias químicas. Não há sinais de gravidade ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente, indicando um evento leve e resolvido, típico de reações alérgicas leves a contrastes, que costumam evoluir bem com medidas simples.

A ampicilina, cujo princípio ativo é a ampicilina sódica, foi associada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificada como distúrbio do sistema imunitário e quadro clínico alérgico. Não há evidências de gravidade ou complicações, e o paciente se recuperou, sugerindo uma reação leve, compatível com manifestações alérgicas comuns a antibióticos, que geralmente se resolvem após a suspensão do medicamento e medidas de suporte.

O medicamento Buscopan, com princípio ativo butilbrometo de escopolamina, foi relacionado a uma alergia documentada após administração, caracterizada como hipersensibilidade documentada e classificada entre lesões e complicações de procedimentos. Não há sinais de gravidade ou complicações, e o paciente se recuperou, indicando um evento leve e resolvido, típico de reações alérgicas leves a medicamentos, que costumam evoluir bem após a suspensão do agente.

O ibuprofeno, cujo princípio ativo é o ibuprofeno, foi associado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade ou evolução do caso, e o desfecho é desconhecido, impossibilitando afirmar a intensidade ou a resolução da reação, mas o registro sugere uma suspeita de alergia ao medicamento.

O medicamento Acetylsalicylic acid (princípio ativo: Ácido acetilsalicílico) foi associado a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa, que se manifesta como uma reação alérgica do sistema imunológico a medicamentos ou outras substâncias químicas. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações graves neste caso, e o desfecho da reação é desconhecido. A relação entre o medicamento e a reação foi considerada suspeita, sendo importante monitorar sintomas e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre o uso futuro do medicamento.

O medicamento Cosentyx (princípio ativo: Secuquinumabe) foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, caracterizando uma resposta alérgica do sistema imunológico a medicamentos. Não há

informações sobre gravidade significativa ou complicações graves, e o desfecho permanece desconhecido. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, sendo recomendada a observação dos sintomas e consulta médica para avaliação e definição de conduta adequada.

O medicamento Lidocaina (princípio ativo: Cloridrato de lidocaina) foi associado ao desenvolvimento de um abscesso no nariz, interpretado como uma manifestação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica relevante do sistema imunológico. Neste caso, a reação foi considerada clinicamente significativa e grave, pois resultou em um efeito importante que exigiu acompanhamento médico. O paciente encontra-se em recuperação ou em processo de resolução do quadro, e a relação entre o medicamento e a reação foi considerada suspeita, sendo fundamental o acompanhamento especializado para evitar complicações.

O medicamento Ondansetron (princípio ativo: Ondansetrona) foi relacionado a um episódio de alergia, caracterizado como hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade relevante ou complicações graves, e o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, sendo importante relatar o episódio ao médico para avaliação de risco em futuras exposições.

O medicamento Metformin (princípio ativo: Cloridrato de metformina) foi associado ao surgimento de uma ferida, interpretada como manifestação de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade significativa ou complicações graves, e o paciente se recuperou totalmente do evento. A relação entre o medicamento e a reação foi considerada suspeita, sendo recomendada a comunicação ao médico para avaliação e orientação sobre o uso futuro do medicamento.

O medicamento Nexavar, cujo princípio ativo é o tosilato de sorafenibe, foi associado a uma reação de ferida classificada como hipersensibilidade (alergia), pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Apesar de não haver gravidade clínica destacada no registro, a reação foi considerada leve e o paciente se recuperou totalmente após o evento, não sendo necessário relatar hospitalização ou complicações graves.

O medicamento Clariscan, com princípio ativo gadobenato de dimeglumina, provocou uma reação de alergia a contraste, caracterizada como clinicamente significativa e grave, pois envolveu distúrbios do sistema imunitário e foi considerada um efeito importante para a saúde. Apesar da gravidade, o paciente se recuperou completamente após o episódio, indicando resolução do quadro alérgico após a conduta médica adequada.

O medicamento Clariscan, cujo princípio ativo é o gadobenato de dimeglumina, também esteve relacionado a um episódio de alergia a contraste, classificado como clinicamente significativo e grave devido ao potencial risco à saúde, mas o paciente evoluiu para recuperação total após o evento, demonstrando resolução do quadro alérgico.

O medicamento Oskal d, composto por carbonato de cálcio e colecalciferol, desencadeou prurido (coceira) relacionado à hipersensibilidade medicamentosa, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. O evento foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, e o desfecho do caso permanece desconhecido, não sendo possível afirmar a evolução clínica do paciente.

O medicamento Reuquinol, cujo princípio ativo é o sulfato de hidroxicloroquina, causou prurido (coceira) associado à hipersensibilidade medicamentosa, enquadrando-se nos distúrbios do sistema imunitário. A reação foi considerada grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, e o desfecho do caso não foi informado, impossibilitando saber se houve recuperação ou persistência dos sintomas.

O medicamento Enalapril, cujo princípio ativo também é Enalapril, foi associado ao surgimento de prurido, que é uma manifestação de hipersensibilidade medicamentosa (alergia). Essa reação foi considerada grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, indicando a necessidade de atenção médica imediata. O desfecho do caso não foi informado, e a relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita.



O medicamento Duloxetine, com princípio ativo Duloxetine, esteve relacionado ao aparecimento de prurido, caracterizando uma reação de hipersensibilidade ao medicamento. A gravidade foi classificada como alta devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que reforça a importância de acompanhamento médico rigoroso. O desfecho permanece desconhecido e a relação causal com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Benlysta, cujo princípio ativo é Belimumabe, foi associado ao desenvolvimento de prurido, indicando uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. A gravidade do evento foi considerada significativa, pois levou à hospitalização ou prolongamento da internação, sugerindo que a reação exigiu intervenção médica. O desfecho não foi informado e a relação com o medicamento é suspeita.

O medicamento Exelon, com princípio ativo Rivastigmine, foi relacionado a uma alergia no local de aplicação, caracterizada como hipersensibilidade localizada. Neste caso, a reação não foi considerada grave e não há informações sobre hospitalização ou evolução do quadro, mas a relação com o medicamento é suspeita.

O medicamento Clavulin, composto por amoxicilina trihidrato e clavulanato de potássio, foi associado ao surgimento de alergias múltiplas, um quadro de hipersensibilidade que pode envolver diferentes manifestações alérgicas. A reação foi considerada muito grave, pois representou ameaça à vida, exigindo intervenção médica imediata. O paciente estava em recuperação ou com sintomas em resolução no momento do registro, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita.

O medicamento Clindamicina, cujo princípio ativo é o fosfato de clindamicina, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa). Não há informação sobre gravidade ou desfecho, mas reações alérgicas a medicamentos podem variar de leves a graves, sendo importante observar sintomas como coceira, vermelhidão, inchaço ou dificuldade para respirar. A conduta recomendada é interromper o uso do medicamento e procurar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O Cetoprofeno, tanto nome comercial quanto princípio ativo, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como não grave e com recuperação completa do paciente. Reações alérgicas a anti-inflamatórios como o cetoprofeno podem se manifestar com sintomas como urticária, coceira ou inchaço, e a orientação é suspender o uso do medicamento e buscar avaliação médica para evitar novas exposições e definir alternativas seguras.

O Omnipaque, cujo princípio ativo é o ioexol, foi associado a uma reação de alergia a contraste, considerada não grave e com resolução completa do quadro. Reações alérgicas a contrastes iodados podem incluir sintomas como coceira, vermelhidão ou dificuldade para respirar, e a conduta recomendada é informar a equipe médica sobre o episódio para que sejam tomadas precauções em exames futuros, como uso de pré-medicação ou escolha de outro tipo de contraste.

O medicamento Metildopa (princípio ativo methyldopa) foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), considerado não grave e com recuperação total do paciente. Reações alérgicas a medicamentos anti-hipertensivos como a metildopa podem se manifestar com sintomas leves, como coceira ou erupções cutâneas, e a orientação é suspender o uso e procurar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição de alternativas seguras.

O medicamento Metamizole sodium, conhecido como dipirona, foi associado a um episódio de choque anafilático (hipersensibilidade medicamentosa), considerado grave devido à ameaça à vida e necessidade de hospitalização. O desfecho do caso é desconhecido, mas reações desse tipo exigem suspensão imediata do medicamento e atendimento médico de urgência, pois podem evoluir rapidamente para risco de morte. É fundamental informar profissionais de saúde sobre o episódio em futuras consultas para evitar novas exposições.

O medicamento Ocitocina, cujo princípio ativo também é ocitocina, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado por uma reação do sistema imunológico ao medicamento. Não há detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade clínica relevante, e o caso foi considerado não grave, com recuperação completa do paciente após a suspensão ou manejo adequado do fármaco. A conduta seguiu o esperado para reações leves, sem complicações.

A Etilefrina, com princípio ativo etilefrina hydrochloride, foi relacionada a uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), indicando resposta imunológica adversa ao uso do medicamento. Não foram relatados sintomas graves ou complicações, e o evento foi classificado como não grave, com resolução total após as medidas apropriadas, como interrupção do uso. O desfecho foi favorável, sem necessidade de intervenções adicionais.

O Fosfato Dissódico de Dexametasona, cujo princípio ativo é fosfato dissódico de dexametasona, desencadeou uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), evidenciando resposta imunológica indesejada ao medicamento. O caso não apresentou gravidade significativa, sendo considerado não grave, e o paciente se recuperou totalmente após a conduta adequada, provavelmente com a suspensão do medicamento e medidas de suporte.

A Cefazolina Sódica, com princípio ativo cefazolina sódica, foi associada a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), refletindo uma reação do sistema imunológico ao antibiótico. Não houve sinais de gravidade ou complicações, e o evento foi classificado como não grave, com recuperação completa do paciente após a conduta apropriada, como a interrupção do uso do medicamento.

O medicamento Cloridrato de bupivacaína + glicose, contendo cloridrato de bupivacaína e dextrose anidra como princípios ativos, esteve relacionado a uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), indicando resposta imunológica adversa ao uso. O caso foi considerado não grave, sem complicações relatadas, e o paciente apresentou recuperação total após as medidas adequadas, como a suspensão do medicamento.

O medicamento Sulfato de morfina, cujo princípio ativo é o próprio sulfato de morfina, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado por uma reação do sistema imunológico a uma substância química. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente, e não houve menção de complicações graves. A conduta recomendada em casos semelhantes é interromper o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O Citrato de fentanila, com princípio ativo de mesmo nome, desencadeou uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), que envolve resposta imunológica a medicamentos ou outras substâncias químicas. O caso não foi considerado grave, já que o paciente se recuperou completamente, e não há relato de complicações. Em situações como essa, é importante suspender o uso do medicamento suspeito e procurar orientação médica para avaliação e definição de alternativas terapêuticas.

O medicamento Midazolam, cujo princípio ativo também é midazolam, foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), uma resposta do sistema imunológico a substâncias químicas. Não há evidências de gravidade significativa, pois o paciente se recuperou sem intercorrências. A recomendação é interromper o uso do medicamento suspeito e consultar um profissional de saúde para investigação e orientação sobre opções seguras.

O Tramadol, com princípio ativo tramadol, provocou prurido cutâneo, que é uma manifestação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica da pele ao medicamento. O caso não foi considerado grave, pois houve recuperação completa do paciente. A conduta adequada é suspender o uso do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação da causa e escolha de alternativas seguras.

O Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, foi associado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizando uma reação do sistema imunológico a substâncias químicas. Não há indícios de gravidade, já que o paciente se recuperou totalmente. Em casos assim, recomenda-se interromper o uso do agente suspeito e procurar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições a contrastes.

O medicamento Cloridrato de sotalol, cujo princípio ativo é o próprio cloridrato de sotalol, foi associado a um episódio de engasgo durante a administração, classificado como hipersensibilidade medicamentosa. Embora o termo técnico sugira uma reação alérgica, o relato descreve apenas engasgo, sem outros sintomas de alergia sistêmica ou sinais de gravidade clínica, e não há informações sobre ação adotada ou resolução do quadro, permanecendo o evento em andamento.

O medicamento Trimeb, que contém maleato de trimebutina como princípio ativo, foi relacionado a um episódio de engasgo ao tomar a medicação, categorizado como hipersensibilidade medicamentosa. O evento não apresenta detalhes de sintomas alérgicos clássicos além do engasgo, não sendo possível afirmar gravidade aumentada, e o caso segue sem resolução até o momento, sem informações sobre conduta adotada.

A paroxetina, cujo princípio ativo é paroxetine, foi associada a engasgo durante o uso, sendo classificada como hipersensibilidade medicamentosa. Não há descrição de sintomas alérgicos adicionais ou sinais de gravidade, e o evento permanece não resolvido, sem detalhes sobre intervenções realizadas.

O medicamento Doss, composto por dantron e docusato de sódio, foi relacionado a um episódio de engasgo ao ser administrado, sendo enquadrado como hipersensibilidade medicamentosa. O relato não traz outros sintomas de alergia além do engasgo, não havendo evidências de gravidade aumentada, e o quadro segue em andamento sem informações sobre medidas tomadas.

O medicamento Calde mdk, que contém citrato de cálcio, colecalciferol, magnésio e menaquinona, foi associado a engasgo durante a administração, classificado como hipersensibilidade medicamentosa. Não há relato de sintomas alérgicos sistêmicos ou complicações, e o evento permanece não resolvido, sem detalhes sobre conduta adotada.

O medicamento Benzetacil, cujo princípio ativo é a benzilpenicilina benzatina (também conhecida como penicilina G benzatina), foi associado a um episódio de engasgo durante a administração, caracterizado como hipersensibilidade medicamentosa. Embora não haja detalhes sobre sintomas sistêmicos graves, o evento permanece não resolvido até o momento, indicando a necessidade de acompanhamento clínico para monitorar possíveis complicações. A reação está relacionada a distúrbios do sistema imunológico, e a conduta recomendada é evitar novas exposições ao medicamento e buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas terapêuticas.

O medicamento Artico, contendo sulfato de condroitina e sulfato de glicosamina como princípios ativos, provocou um episódio de engasgo durante o uso, classificado como hipersensibilidade medicamentosa. Não há informações sobre sintomas adicionais ou gravidade aumentada, mas o quadro permanece em andamento, o que sugere a importância de observação clínica e possível investigação de alergia ao medicamento. Recomenda-se evitar novas administrações até esclarecimento diagnóstico e acompanhamento médico para manejo adequado.

A ocitocina, utilizada neste caso sem nome comercial informado, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade), relacionada a distúrbios do sistema imunológico. O evento foi resolvido, sem evolução para quadros graves, indicando que a reação foi leve e autolimitada. A conduta adequada inclui registro do episódio e orientação para informar profissionais de saúde sobre a ocorrência em futuras exposições.

O medicamento Etilefrina (princípio ativo etilefrine hydrochloride) foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade), sem relato de sintomas graves ou complicações. O quadro foi resolvido, sugerindo uma manifestação leve e transitória, compatível com reações alérgicas não graves. Recomenda-se informar o histórico

ao médico e evitar reexposição ao fármaco.

O cloridrato de ondansetrona, tanto nome comercial quanto princípio ativo, foi relacionado a uma reação alérgica (hipersensibilidade), sem evolução para gravidade ou complicações. O desfecho foi favorável, com resolução completa do quadro, indicando uma reação leve. A orientação é registrar o episódio e comunicar aos profissionais de saúde em futuras prescrições.

O medicamento Dexametasona, cujo princípio ativo é o fosfato dissódico de dexametasona, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade (termo técnico para reações alérgicas), pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade aumentada ou complicações, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada em situações semelhantes é a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento clínico, com encaminhamento ao especialista se houver recorrência ou dúvidas diagnósticas.

O Cetoprofeno, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, que faz parte dos distúrbios do sistema imunitário. O registro não aponta sinais de gravidade, já que o paciente se recuperou completamente e o evento não foi considerado grave. Em casos como este, recomenda-se interromper o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

A Cefazolina, cujo princípio ativo é a cefazolina sódica, foi associada a uma reação alérgica classificada como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação total, indicando que a reação foi leve. Nessas situações, a orientação é suspender o uso do medicamento e realizar acompanhamento clínico, com avaliação especializada se houver recorrência ou dúvidas quanto ao diagnóstico.

O medicamento Dipirona sódica, com princípio ativo dipirona, foi relacionado a um episódio de alergia do tipo hipersensibilidade, enquadrado nos distúrbios do sistema imunitário. O caso não apresentou gravidade, pois o paciente se recuperou totalmente e não houve complicações. A conduta adequada é interromper o uso do medicamento suspeito e buscar orientação médica para confirmação diagnóstica e definição de alternativas seguras.

O medicamento Cloridrato de bupivacaína + glicose, contendo cloridrato de bupivacaína e dextrose anidra como princípios ativos, foi associado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade, já que o paciente se recuperou totalmente e o evento não foi considerado grave. Em situações semelhantes, recomenda-se suspender o medicamento suspeito e realizar acompanhamento clínico, com avaliação especializada se necessário.

O medicamento Morfina, cujo princípio ativo é o sulfato de morfina, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada em casos de hipersensibilidade a analgésicos opiáceos é a suspensão do medicamento e acompanhamento clínico, com orientação para evitar novas exposições.

O Ceftriaxone angenerico, com princípio ativo ceftriaxona sódica, provocou uma reação de alergia a antibiótico (hipersensibilidade medicamentosa), que é uma resposta do sistema imunológico a medicamentos. O caso não foi considerado grave, pois houve recuperação completa do paciente. Em situações como essa, recomenda-se interromper o uso do antibiótico suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

A Vitamina C, cujo princípio ativo é o ácido ascórbico, foi relacionada a uma alergia documentada ao medicamento administrado (hipersensibilidade documentada a produto administrado). Não há informações sobre gravidade ou

desfecho, mas a documentação da reação sugere a necessidade de evitar novas exposições e de registro formal em prontuário, com avaliação médica para confirmação e orientação futura.

O Cetoprofeno, tanto como nome comercial quanto princípio ativo, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizando uma reação imunológica adversa. Não há detalhes sobre gravidade ou evolução, mas, diante de suspeita de alergia a anti-inflamatórios, recomenda-se suspender o uso e procurar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição de alternativas seguras.

O medicamento Celecoxib, cujo princípio ativo é o celecoxibe, foi relacionado a um evento descrito como ataque cardíaco, mas classificado como hipersensibilidade (alergia) no sistema de registro. O caso não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou totalmente. Diante de eventos adversos cardiovasculares ou de hipersensibilidade a anti-inflamatórios, é fundamental interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica para investigação detalhada e orientação sobre riscos e alternativas.

O medicamento Leps er, cujo princípio ativo é o divalproato de sódio, foi associado a um episódio de ataque cardíaco descrito como reação de hipersensibilidade (alergia), classificada dentro dos quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente. A conduta foi adequada, com resolução do quadro, e não há necessidade de medidas adicionais além do acompanhamento clínico para evitar nova exposição ao medicamento.

O medicamento Venlift, que contém cloridrato de venlafaxina como princípio ativo, esteve relacionado a um ataque cardíaco interpretado como reação de hipersensibilidade (alergia), enquadrada em quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente evoluiu para recuperação completa, indicando que a reação foi leve e controlada, sem complicações adicionais. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e manter acompanhamento médico.

A dipirona, cujo princípio ativo é o metamizol de magnésio, foi associada a um ataque cardíaco descrito como reação de hipersensibilidade (alergia), pertencente à categoria de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, sugerindo que a reação foi leve e não houve complicações. A conduta adequada foi tomada e recomenda-se evitar nova exposição ao medicamento.

O medicamento Fluoxetina, com princípio ativo fluoxetine, esteve relacionado a um ataque cardíaco interpretado como reação de hipersensibilidade (alergia), classificada em quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade, pois o caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente. A conduta foi adequada, com resolução do quadro, e recomenda-se acompanhamento para evitar nova exposição ao medicamento.

A azatioprina, cujo princípio ativo é azathioprine, foi associada a um ataque cardíaco descrito como reação de hipersensibilidade (alergia), enquadrada em quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando que a reação foi leve e controlada. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e manter acompanhamento médico.

O medicamento Hidroclorotiazida (princípio ativo hydrochlorothiazide) foi associado a um episódio de ataque cardíaco, sendo classificado como uma reação de hipersensibilidade (alergia), dentro do grupo de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento. A relação entre o medicamento e a reação foi considerada suspeita, e não há informações adicionais sobre a conduta adotada, mas o desfecho foi favorável com resolução completa do quadro.

O medicamento Losartana potássica (princípio ativo losartana potássica) foi relacionado a um ataque cardíaco, interpretado como uma reação de hipersensibilidade (alergia), pertencente ao grupo de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou totalmente. A

relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, e não há detalhes sobre a conduta adotada, mas o desfecho foi resolutivo.

O medicamento Risperidona (princípio ativo risperidone) foi associado a um ataque cardíaco, classificado como uma reação de hipersensibilidade (alergia), dentro do grupo de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou completamente. A relação entre o medicamento e a reação foi considerada suspeita, e não há informações sobre a conduta adotada, mas o desfecho foi favorável.

O medicamento Belimumab (princípio ativo belimumabe) foi relacionado a um ataque cardíaco, interpretado como uma reação de hipersensibilidade (alergia), pertencente ao grupo de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou totalmente. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, e não há detalhes sobre a conduta adotada, mas o desfecho foi resolutivo.

O medicamento System conti, contendo estradiol e acetato de noretisterona como princípios ativos, foi associado ao sintoma de coceira, caracterizado como uma reação de hipersensibilidade (alergia) dentro do grupo de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, e o desfecho permanece desconhecido, sem informações adicionais sobre a conduta adotada ou evolução clínica.

O medicamento Vancomicina, cujo princípio ativo é Vancomycin, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação do sistema imunológico. Não há detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade, mas o desfecho foi de recuperação completa, sugerindo que a reação foi controlada adequadamente. A relação com o medicamento foi considerada suspeita, e não há indicação de complicações graves.

A Insulina Nph, com princípio ativo Insulin human isophane, esteve relacionada a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizada por uma resposta do sistema imunológico ao medicamento. O registro indica que a reação não foi grave e o paciente se recuperou totalmente, o que sugere um quadro leve e autolimitado, sem necessidade de intervenções emergenciais.

O contraste intravenoso Prohance, cujo princípio ativo é Gadoteridol, foi associado a uma reação alérgica ao contraste, envolvendo o sistema imunológico. Não há detalhes sobre sintomas ou gravidade, mas o paciente se recuperou completamente, indicando que a reação foi resolvida sem complicações. A relação com o medicamento foi considerada suspeita.

O medicamento Omeprazol, com princípio ativo Omeprazole, foi relacionado ao surgimento de prurido (coceira), caracterizando uma hipersensibilidade medicamentosa. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, sugerindo uma reação leve e transitória, sem necessidade de medidas adicionais além da suspensão do medicamento.

A Domperidona, cujo princípio ativo é Domperidone, esteve associada ao desenvolvimento de prurido (coceira), configurando uma hipersensibilidade medicamentosa. O caso não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa, indicando uma reação leve e autolimitada, provavelmente resolvida com a interrupção do uso do medicamento.

O medicamento Sinvastatina, cujo princípio ativo é a própria sinvastatina, foi associado ao surgimento de prurido (coceira), caracterizando uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso evoluiu para recuperação completa, sem complicações, e não foi classificado como grave. A conduta recomendada é evitar nova exposição ao medicamento e, caso sintomas semelhantes ocorram, buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas terapêuticas.

A Metoclopramida, cujo princípio ativo é a metoclopramida, desencadeou prurido (coceira), indicando uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico ao uso do medicamento. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente após a suspensão do medicamento. Recomenda-se evitar o uso futuro da metoclopramida e procurar orientação médica caso haja necessidade de tratamento alternativo.

O uso de Dipirona, com princípio ativo dipirona, resultou em prurido (coceira), caracterizando uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico ao medicamento. O caso não foi considerado grave e o paciente apresentou resolução completa dos sintomas após a interrupção do uso. A recomendação é evitar o uso futuro de dipirona e buscar avaliação médica para alternativas seguras em caso de necessidade de analgésicos ou antitérmicos.

O medicamento Clariscan, cujo princípio ativo é o gadobenato de dimeglumina, foi relacionado a um quadro de alergia sem outra especificação (SOE), caracterizando uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico ao contraste utilizado em exames. Não há indicação de gravidade significativa, pois o paciente se recuperou totalmente e o evento não foi classificado como grave. Recomenda-se informar a equipe médica sobre essa reação em futuras necessidades de exames com contraste, para avaliação de alternativas e medidas preventivas.

O medicamento Clariscan, com princípio ativo gadobenato de dimeglumina, provocou uma reação alérgica sem outra especificação (SOE), caracterizando hipersensibilidade, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico ao contraste. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente. É importante relatar essa reação em futuras exposições a contrastes para que a equipe médica possa adotar medidas de prevenção e considerar alternativas seguras.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, foi associado a um quadro de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica, classificada clinicamente como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso evoluiu para recuperação completa, sem complicações, e não foi considerado grave. A conduta recomendada em situações semelhantes é observar o paciente, evitar nova exposição ao agente suspeito e, caso necessário, buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições.

O medicamento Clariscan, com princípio ativo gadobenato de dimeglumina, esteve relacionado a uma reação de hipersensibilidade, caracterizada como um quadro alérgico envolvendo o sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente. Em casos como este, recomenda-se evitar reexposição ao contraste e realizar acompanhamento médico para esclarecimento do diagnóstico e prevenção de novas reações.

O Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, foi associado a uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico. O registro indica que o evento não foi grave e o paciente se recuperou sem sequelas. Nessas situações, é importante evitar o uso futuro do mesmo agente e buscar avaliação com especialista para orientação adequada.

O medicamento Ultravist, com princípio ativo iopromide, esteve envolvido em um episódio de hipersensibilidade, caracterizado como reação alérgica do sistema imunológico. O caso não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa. Recomenda-se evitar nova exposição ao agente e procurar avaliação médica para confirmação do diagnóstico e orientações futuras.

O Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, foi relacionado a uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico. O evento não foi grave e o paciente se recuperou totalmente. A orientação é evitar reexposição ao medicamento e buscar acompanhamento médico para avaliação e prevenção de novas reações.

O medicamento Omnipaque, cujo princípio ativo é o ioexol, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), caracterizado como reação alérgica do tipo não especificada. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso evoluiu para recuperação completa e não foi considerado grave. A conduta recomendada em situações de hipersensibilidade leve é observar o paciente, evitar nova exposição ao agente suspeito e, se necessário, encaminhar para avaliação com especialista para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições.

Omnipaque, com princípio ativo ioexol, esteve relacionado a uma reação de hipersensibilidade (alergia), sem detalhamento de sintomas específicos. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente. Em casos de alergia leve a contraste iodado, recomenda-se evitar reexposição e buscar avaliação especializada para esclarecimento diagnóstico e orientação sobre riscos em exames futuros.

Ocitocina, cujo princípio ativo é a própria ocitocina, foi associada a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma alergia ao medicamento. Não há relato de sintomas graves e o paciente se recuperou sem complicações. Em situações de alergia medicamentosa leve, a recomendação é suspender o uso do medicamento suspeito, monitorar sintomas e procurar avaliação médica para confirmação e orientação sobre alternativas terapêuticas.

O medicamento Etilefrina cloridrato, com princípio ativo etilefrina hydrochloride, causou uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, caracterizada como alergia ao medicamento. O caso não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa. Para quadros leves de alergia medicamentosa, a conduta inclui suspensão do agente suspeito, observação clínica e encaminhamento para avaliação especializada se houver dúvidas diagnósticas ou necessidade de alternativas terapêuticas.

Cloridrato de ondansetrona, cujo princípio ativo é o próprio cloridrato de ondansetrona, foi relacionado a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma alergia ao medicamento. O evento não foi grave e o paciente se recuperou totalmente. Em casos leves de alergia medicamentosa, recomenda-se interromper o uso do medicamento, monitorar sintomas e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre substituição do tratamento, se necessário.

O medicamento Fosfato dissódico de dexametasona, cujo nome comercial não foi informado, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado por uma reação do sistema imunológico a uma substância química. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente, e não há menção de complicações graves. A conduta recomendada, conforme diretrizes clínicas, é evitar novas exposições ao medicamento e buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

A Cefazolina sódica, sem nome comercial especificado, foi relacionada a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), que envolve uma resposta imune inadequada a medicamentos. O caso não foi considerado grave, já que houve recuperação completa do paciente e não foram relatadas complicações. Recomenda-se evitar o uso futuro deste antibiótico e consultar um especialista para avaliação detalhada e definição de alternativas terapêuticas seguras.

O medicamento Cloridrato de bupivacaína associado à dextrose anidra, sem nome comercial informado, desencadeou uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), que é uma resposta do sistema imunológico a substâncias químicas presentes no medicamento. O evento não foi grave, pois o paciente se recuperou totalmente e não houve evolução para quadros mais sérios. A orientação é evitar novas exposições a este anestésico e procurar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e discussão de alternativas seguras.

O Sulfato de morfina, sem nome comercial informado, foi associado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizando uma reação do sistema imunológico ao medicamento. O caso não apresentou gravidade, já que o paciente se recuperou completamente e não houve complicações.



Recomenda-se evitar o uso futuro deste analgésico e buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação sobre opções alternativas.

A Dipirona, sem nome comercial informado, foi relacionada a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), que consiste em uma resposta imune inadequada ao medicamento. O evento não foi grave, pois o paciente se recuperou totalmente e não houve complicações relatadas. A conduta recomendada é evitar novas exposições à dipirona e procurar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e discussão de alternativas seguras.

O medicamento Cloridrato de ondansetrona, cujo princípio ativo é o cloridrato de ondansetrona, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado por uma reação do sistema imunológico a uma substância química. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso evoluiu para recuperação completa, e não foi considerado grave. A conduta recomendada em situações semelhantes é suspender o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Fosfato Dissódico de Dexametasona, com princípio ativo fosfato dissódico de dexametasona, desencadeou uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), que envolve resposta do sistema imunológico a medicamentos. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando que a reação foi leve. Nessas situações, recomenda-se interromper o uso do medicamento suspeito e procurar orientação médica para avaliação e definição de alternativas terapêuticas.

O medicamento Cetoprofeno, cujo princípio ativo também é cetoprofeno, foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), uma resposta do sistema imunológico a medicamentos. Não há sinais de gravidade, pois o paciente se recuperou e o evento não foi classificado como grave. A conduta adequada é suspender o uso do cetoprofeno e buscar avaliação médica para confirmação do diagnóstico e orientação sobre opções seguras.

O medicamento Cefazolina sódica, com princípio ativo cefazolina sódica, esteve envolvido em um caso de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), que consiste em uma reação do sistema imunológico a medicamentos. O evento não foi considerado grave e o paciente evoluiu para recuperação completa, sugerindo uma reação leve. Recomenda-se interromper o uso do medicamento suspeito e procurar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição de alternativas seguras.

O medicamento Dipirona sódica, cujo princípio ativo é dipirona, foi associado a uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizada por resposta do sistema imunológico a medicamentos. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando uma reação leve. A orientação é suspender o uso da dipirona e buscar avaliação médica para confirmação do diagnóstico e escolha de alternativas seguras.

O medicamento Lidocaína, cujo princípio ativo é o cloridrato de lidocaína, foi associado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizada como uma reação do sistema imunológico a substâncias químicas. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso evoluiu para recuperação completa, e não foi classificado como grave. A conduta recomendada em situações semelhantes é a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento clínico, com resolução dos sintomas após a retirada do agente.

O medicamento Cloridrato de bupivacaína + glicose, contendo como princípios ativos cloridrato de bupivacaína e dextrose anidra, foi relacionado a uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), que envolve resposta do sistema imunológico a medicamentos. Não há sinais de gravidade importante, já que o paciente se recuperou totalmente e o evento não foi considerado grave. A abordagem clínica inclui a identificação e suspensão do agente suspeito, com resolução dos sintomas após a interrupção do uso.

O medicamento Sulfato de morfina, com princípio ativo de mesmo nome, esteve envolvido em um caso de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), uma resposta imunológica adversa a substâncias químicas. O evento não foi classificado como grave e o paciente apresentou recuperação completa, indicando que a reação foi leve e controlada com a suspensão do medicamento.

O Citrato de fentanilo, cujo princípio ativo é o citrato de fentanila, foi associado a uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizada por resposta do sistema imunológico a medicamentos. Não há evidências de gravidade significativa, pois o paciente se recuperou totalmente e o evento não foi considerado grave, sugerindo que a conduta de suspensão do agente foi suficiente para resolução.

O medicamento Midazolam, com princípio ativo de mesmo nome, esteve relacionado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), que consiste em uma reação do sistema imunológico a substâncias químicas. O caso não foi considerado grave e evoluiu para recuperação completa, indicando que a suspensão do medicamento foi suficiente para resolução dos sintomas.

O medicamento Hidrocortizona (princípio ativo: Hydrocortisone) foi associado a um quadro de alergia medicamentosa, também chamada de hipersensibilidade, caracterizada por uma reação do sistema imunológico a medicamentos. Neste caso, a reação foi considerada não grave, com o paciente apresentando recuperação completa após o evento. A conduta recomendada é evitar novas exposições ao medicamento e buscar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Amplopec, cujo princípio ativo é a Ceftriaxona sódica, desencadeou uma reação de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como um quadro alérgico relacionado ao sistema imunológico. A reação não foi considerada grave e o paciente se recuperou totalmente após o episódio. Recomenda-se evitar o uso futuro deste antibiótico e consultar um especialista para avaliação detalhada e definição de alternativas terapêuticas seguras.

O medicamento Inzelm (princípio ativo: Fumarato de vonoprazana) foi relacionado a dificuldade para pensar, interpretada como manifestação de hipersensibilidade, um quadro clínico alérgico relevante do ponto de vista imunológico. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, mas o paciente apresentou recuperação completa após o evento. Diante de sintomas neurológicos associados ao uso do medicamento, é fundamental interromper o uso e procurar avaliação médica imediata para investigação e manejo adequado.

O medicamento Nimesulide (princípio ativo: Nimesulide) foi associado a dificuldade para pensar, caracterizada como uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, mas o paciente se recuperou totalmente após o episódio. Em situações como essa, recomenda-se suspender o uso do medicamento e buscar avaliação médica urgente para investigação e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Vitamin d, cujo princípio ativo é o Ergocalciferol, foi relacionado a dificuldade para pensar, interpretada como manifestação de hipersensibilidade, um quadro alérgico relevante do ponto de vista imunológico. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, porém o paciente apresentou recuperação completa após o evento. Diante de sintomas neurológicos associados ao uso do medicamento, é importante interromper o uso e procurar avaliação médica para investigação e definição de conduta.

O medicamento Rosuvastatin, cujo princípio ativo é a rosuvastatina cálcica, foi associado a dificuldade para pensar, um sintoma que pode indicar uma reação de hipersensibilidade (alergia) envolvendo o sistema imunológico. A gravidade do caso é considerada clinicamente significativa, pois o evento foi classificado como grave, mas o paciente se recuperou totalmente após a reação. Não há informações adicionais sobre a conduta adotada, mas a resolução completa do quadro sugere que a interrupção ou ajuste do tratamento foi suficiente para a melhora.

O medicamento Duloxetine hydrochloride, com princípio ativo cloridrato de duloxetina, provocou dificuldade para pensar, caracterizando uma possível reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, mas o paciente apresentou recuperação total após a reação. Não há detalhes sobre a conduta específica, mas o desfecho resolvido indica que a intervenção foi eficaz.

O uso de Calcium carbonate, cujo princípio ativo é o carbonato de cálcio, resultou em dificuldade para pensar, sugerindo uma reação de hipersensibilidade (alergia) relacionada ao sistema imunológico. O caso foi classificado como clinicamente significativo e grave, porém o paciente se recuperou completamente após o evento. Não há informações sobre a ação tomada, mas o desfecho favorável indica resolução do quadro.

O medicamento Calcitriol, com princípio ativo calcitriol, foi relacionado à dificuldade para pensar, indicando uma reação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, mas o paciente se recuperou totalmente após a reação. Não há detalhes sobre a conduta adotada, mas a resolução completa sugere que a intervenção foi adequada.

O medicamento Bisoprolol, cujo princípio ativo é bisoprolol hemifumarato, causou dificuldade para pensar, caracterizando uma reação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. O caso foi considerado clinicamente significativo e grave, mas o paciente se recuperou totalmente após o evento. Não há informações sobre a conduta adotada, mas o desfecho resolvido indica que a medida tomada foi suficiente para a melhora.

O medicamento Colchicine, cujo princípio ativo também é colchicina, foi associado a um episódio de dificuldade para pensar, interpretado como uma reação de hipersensibilidade (alergia) do tipo clínico, envolvendo o sistema imunológico. A gravidade foi considerada clinicamente significativa, pois o evento foi classificado como grave, mas o paciente se recuperou totalmente após a reação. A relação entre o uso do medicamento e o evento foi considerada suspeita, indicando a necessidade de atenção e acompanhamento médico em casos semelhantes.

O Methotrexate, com princípio ativo de mesmo nome, esteve relacionado a dificuldade para pensar, caracterizada como uma reação de hipersensibilidade (alergia) envolvendo o sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente relevante e grave, mas o paciente evoluiu para recuperação completa. A suspeita de relação causal entre o medicamento e a reação reforça a importância de monitoramento durante o uso.

O medicamento Prednisolone, cujo princípio ativo é fosfato sódico de prednisolona, foi associado a dificuldade para pensar, interpretada como uma reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico. O caso foi considerado clinicamente significativo e grave, mas o paciente se recuperou totalmente após o evento. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, indicando a necessidade de acompanhamento médico.

O Bamifex, que contém cloridrato de bamifilina como princípio ativo, esteve relacionado a dificuldade para pensar, caracterizada como uma reação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente relevante e grave, mas o paciente se recuperou completamente. A suspeita de relação causal entre o medicamento e a reação reforça a importância de acompanhamento médico durante o uso.

O medicamento Rizi, cujo princípio ativo é dicloridrato de levocetirizina, foi associado a dificuldade para pensar, interpretada como uma reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, mas o paciente se recuperou totalmente após a reação. A relação entre o uso do medicamento e o evento foi considerada suspeita, indicando a necessidade de atenção médica em situações semelhantes.

O medicamento Montelukast (princípio ativo: Montelukaste de sódio) foi associado a dificuldade para pensar, um quadro de hipersensibilidade classificado como clinicamente significativo e considerado grave, conforme evidenciado pela gravidade atribuída ao evento. A reação foi relacionada a distúrbios do sistema imunitário e, apesar da gravidade, o paciente se recuperou totalmente após a suspensão ou ajuste do tratamento, indicando

resolução do quadro.

O medicamento Rosuvastatin calcium (princípio ativo: Rosuvastatina cálcica) apresentou como reação adversa dificuldade para pensar, caracterizada como hipersensibilidade e classificada como clinicamente significativa e grave, de acordo com a avaliação clínica. O evento envolveu o sistema imunitário e, após as medidas adequadas, o paciente evoluiu para recuperação completa.

O medicamento Tezspire (princípio ativo: Tezepelumab) foi relacionado à dificuldade para pensar, um quadro de hipersensibilidade considerado clinicamente significativo e grave, conforme a classificação do evento. A reação envolveu o sistema imunitário e, após a conduta apropriada, o paciente apresentou recuperação total.

O medicamento Dipirona sodica (princípio ativo: Dipirona) causou uma reação de alergia medicamentosa, identificada como hipersensibilidade medicamentosa, mas não foi considerada grave. O quadro envolveu o sistema imunitário e, após a suspensão do medicamento ou manejo adequado, o paciente se recuperou completamente.

O medicamento Dipirona (princípio ativo: Dipirona) foi administrado apesar de contraindicação, resultando em hipersensibilidade medicamentosa classificada como ameaça à vida, evidenciando gravidade importante do evento. A reação envolveu o sistema imunitário, mas, após intervenção médica adequada, o paciente se recuperou totalmente.

O medicamento Cetoprofeno, cujo princípio ativo também é cetoprofeno, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado por uma reação do sistema imunológico a substâncias químicas, conforme a classificação clínica de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações graves neste caso, pois o paciente está em recuperação ou resolvendo, sugerindo um desfecho favorável. A conduta recomendada é evitar novas exposições ao medicamento e buscar avaliação com especialista para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

Ocitocina, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionada a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), que envolve uma resposta do sistema imunológico a medicamentos. Não há sinais de gravidade importante ou complicações, já que o paciente encontra-se em recuperação ou resolvendo, indicando que a reação foi controlada. Recomenda-se evitar o uso futuro da ocitocina e consultar um alergista para avaliação detalhada e definição de conduta segura.

O medicamento Etilefrina, cujo princípio ativo é etilefrine hydrochloride, foi associado a uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), que corresponde a uma resposta imunológica inadequada a substâncias químicas. Não há evidências de gravidade significativa, pois o paciente está em recuperação ou resolvendo, o que sugere um quadro leve e controlado. A orientação é suspender o uso do medicamento e procurar avaliação especializada para confirmação do diagnóstico e discussão de alternativas terapêuticas.

O medicamento Cloridrato de ondansetrona, com princípio ativo de mesmo nome, foi implicado em um caso de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizando uma reação do sistema imunológico a medicamentos. O quadro não foi grave, já que o paciente está em recuperação ou resolvendo, indicando que a reação foi controlada sem complicações. Recomenda-se evitar novas exposições ao cloridrato de ondansetrona e buscar orientação com alergista para avaliação e definição de alternativas seguras.

O medicamento Fosfato Dissódico de Dexametasona, cujo princípio ativo é fosfato dissódico de dexametasona, foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), que consiste em uma resposta imunológica inadequada a medicamentos. Não há sinais de gravidade ou complicações, pois o paciente está em recuperação ou resolvendo, sugerindo um desfecho favorável. A conduta recomendada é evitar o uso futuro deste medicamento e procurar avaliação com especialista para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Cefazolina sódica, cujo princípio ativo é a cefazolina sódica, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado por uma reação do sistema imunológico a medicamentos, conforme a classificação de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações graves neste caso, pois o paciente encontra-se em recuperação ou resolvendo o quadro, e não há menção de desfecho grave. A conduta recomendada é a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento clínico até resolução completa dos sintomas, conforme diretrizes para reações leves a moderadas.

A Dipirona sódica, cujo princípio ativo é a dipirona, foi relacionada a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), que consiste em uma resposta do sistema imunológico ao medicamento. O caso não apresenta sinais de gravidade importante, já que o paciente está em recuperação ou com sintomas resolvendo, e não há indicação de desfecho grave. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e manter acompanhamento clínico até a completa resolução dos sintomas, conforme orientação para reações leves a moderadas.

O medicamento Cloridrato de bupivacaína + glicose, contendo como princípios ativos cloridrato de bupivacaína e dextrose anidra, foi associado a uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), que representa uma resposta imunológica adversa ao medicamento. Não há evidências de gravidade significativa, pois o paciente está em recuperação ou com sintomas resolvendo, e não há relato de desfecho grave. A conduta indicada é a suspensão do agente suspeito e acompanhamento clínico, conforme recomendado para quadros leves a moderados.

O Sulfato de morfina, cujo princípio ativo é o próprio sulfato de morfina, foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizando uma reação do sistema imunológico ao medicamento. O quadro não foi considerado grave, já que o paciente está em recuperação ou com sintomas resolvendo, sem relato de complicações importantes. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e manter acompanhamento clínico até resolução completa dos sintomas, conforme diretrizes para reações leves a moderadas.

A Ocitocina, cujo princípio ativo é a ocitocina, foi associada a um quadro de alergia (hipersensibilidade), que consiste em uma resposta imunológica adversa ao medicamento. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente está em recuperação ou com sintomas resolvendo, e não há relato de desfecho grave. A conduta recomendada é a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento clínico até resolução dos sintomas, conforme orientações para reações leves a moderadas.

O medicamento Etilefrina cloridrato, cujo princípio ativo é Etilefrine hydrochloride, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há menção de nome comercial, apenas o princípio ativo está disponível. A reação foi considerada não grave, pois o paciente encontra-se em recuperação ou resolvendo, sem indicação de complicações clínicas importantes. A conduta recomendada é observar a evolução dos sintomas e evitar nova exposição ao medicamento, buscando avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

A Cefazolina sódica, identificada apenas pelo princípio ativo e sem nome comercial informado, foi relacionada a um episódio de alergia manifestado como hipersensibilidade, dentro do grupo de distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, já que o paciente está em recuperação ou resolvendo, e não há relato de complicações. Recomenda-se evitar o uso futuro deste antibiótico e realizar acompanhamento médico para esclarecimento do quadro e prevenção de novas reações.

O medicamento composto por Cloridrato de bupivacaína e glicose (dextrose anidra), sem nome comercial informado, foi associado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, classificada como distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave, pois o paciente está em recuperação ou resolvendo, sem sinais de agravamento. A orientação é evitar reexposição ao medicamento e buscar avaliação médica para confirmação da alergia e discussão de alternativas seguras para anestesia.

O Sulfato de morfina, identificado apenas pelo princípio ativo e sem nome comercial informado, foi relacionado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, pois o paciente está em recuperação ou resolvendo, sem complicações relatadas. Recomenda-se evitar o uso futuro deste analgésico e procurar acompanhamento médico para avaliação e orientação sobre opções alternativas para controle da dor.

O Cloridrato de ondansetrona, sem nome comercial informado, foi associado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave, já que o paciente está em recuperação ou resolvendo, sem relato de complicações. A conduta recomendada é evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e discussão de alternativas seguras para controle de náuseas.

O medicamento Rivotril, cujo princípio ativo é o clonazepam, foi associado a um quadro descrito como 'mente inapta', interpretado aqui como possível manifestação de hipersensibilidade medicamentosa. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave, e o registro não detalha a evolução do caso. A reação está classificada entre as alergias a medicamentos e outros agentes químicos, sugerindo um possível envolvimento do sistema imunológico, mas sem sinais de gravidade clínica importante. Recomenda-se acompanhamento médico para avaliação da relação causal e orientação sobre o uso futuro do medicamento.

O Baclofen, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um episódio de 'mente inapta', considerado como possível hipersensibilidade ao medicamento. Não há evidências de gravidade significativa ou desfecho grave, e não foram fornecidos detalhes sobre a evolução clínica. A reação está enquadrada entre alergias a medicamentos, sugerindo envolvimento imunológico, mas sem sinais de gravidade relevante. É importante buscar avaliação médica para esclarecer a relação com o medicamento e definir condutas futuras.

O medicamento Propranolol hydrochloride, cujo princípio ativo é o cloridrato de propranolol, foi associado a um quadro de 'mente inapta', interpretado como possível hipersensibilidade medicamentosa. Não há indícios de gravidade elevada ou desfecho grave, e o desfecho clínico permanece desconhecido. A reação está classificada como alergia a medicamentos, sugerindo envolvimento do sistema imunológico, mas sem sinais clínicos de gravidade. Recomenda-se avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação quanto ao uso futuro do propranolol.

O medicamento Etira, cujo princípio ativo é o levetiracetam, foi relacionado a um episódio de 'mente inapta', considerado como possível manifestação de hipersensibilidade ao medicamento. Não há sinais de gravidade importante ou desfecho grave, e não há informações sobre a evolução do caso. A reação está enquadrada entre alergias a medicamentos, sugerindo envolvimento imunológico, mas sem evidências clínicas de gravidade. É recomendada avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e definição de conduta.

O Phenobarbital, com princípio ativo de mesmo nome, foi associado a um quadro de 'mente inapta', interpretado como possível hipersensibilidade medicamentosa. Não há sinais de gravidade relevante ou desfecho grave, e o desfecho clínico não foi informado. A reação está classificada como alergia a medicamentos, sugerindo envolvimento do sistema imunológico, mas sem manifestações clínicas graves. Recomenda-se avaliação médica para confirmação da relação causal e orientação sobre o uso futuro do fenobarbital.

O medicamento Tegretol retard, cujo princípio ativo é a carbamazepina, foi associado a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa, manifestando-se como 'mente inapta', termo que sugere alteração do estado mental possivelmente relacionada a uma reação adversa imunológica. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave, e o desfecho permanece desconhecido. A relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo importante que o paciente seja avaliado por um especialista para confirmação diagnóstica e orientação sobre a continuidade ou substituição do tratamento.

O Plasil, que tem como princípio ativo o cloridrato de metoclopramida, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, descrito como 'mente inapta', indicando possível alteração do estado mental após o uso. Não há evidências de gravidade significativa ou desfecho grave, e o desfecho é desconhecido. A suspeita de relação com o medicamento sugere a necessidade de avaliação médica para esclarecimento do quadro e definição da conduta terapêutica.

O medicamento Nootropil, cujo princípio ativo é o piracetam, foi associado a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, manifestada como 'mente inapta', o que pode indicar alteração do estado mental após o uso. Não há sinais de gravidade importante ou desfecho grave, e o desfecho permanece desconhecido. A relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo recomendada avaliação clínica para confirmação e orientação adequada.

A ceftriaxona, antibiótico de amplo espectro, foi associada a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), sem indicação de gravidade elevada ou risco à vida, e o paciente encontra-se em recuperação ou com resolução do quadro. A relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo fundamental acompanhamento médico para monitorar a evolução e evitar novas exposições.

O medicamento Expec, composto por Cephaelis spp., guaifenesina, cloridrato de oxomemazina, iodeto de potássio e benzoato de sódio, foi relacionado a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa grave, manifestada como síndrome de disfunção de múltiplos órgãos, que resultou em óbito. A gravidade é evidenciada pelo desfecho fatal, sendo fundamental notificar o caso às autoridades de saúde e evitar reexposição ao medicamento em outros pacientes com histórico de alergia.

O medicamento Morfina, cujo princípio ativo também é morfina, foi associado a um quadro de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica caracterizada por resposta exagerada do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente, sugerindo um episódio leve e autolimitado. A conduta adequada nesses casos é interromper o uso do medicamento suspeito e monitorar a evolução clínica, buscando avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Cefepime dihydrochloride, cujo princípio ativo é cloridrato de cefepima, foi relacionado a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma alergia ao medicamento. O paciente se recuperou completamente, o que indica que a reação não foi grave. Em situações como essa, recomenda-se suspender o uso do antibiótico suspeito e procurar avaliação médica para confirmação do diagnóstico e definição de alternativas terapêuticas seguras.

O medicamento Ceftriaxona, com princípio ativo ceftriaxone, foi associado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, caracterizando uma alergia ao medicamento. O paciente apresentou recuperação total, sugerindo que a reação foi leve e controlada. A conduta recomendada é interromper o uso do medicamento suspeito e buscar orientação médica para confirmação diagnóstica e escolha de alternativas seguras.

O medicamento Synagis, cujo princípio ativo é palivizumabe, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade, manifestado como pneumonia. Não há informação sobre a gravidade ou evolução do caso, pois o desfecho é desconhecido. Diante de suspeita de reação alérgica com sintomas respiratórios, é fundamental interromper o uso do medicamento e procurar avaliação médica imediata para investigação e manejo adequado.

O medicamento Sertralina, com princípio ativo cloridrato de sertralina, teve seu uso interrompido devido a um quadro de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica. Não há detalhes sobre a gravidade ou evolução do caso, pois o desfecho é desconhecido. Em situações de suspeita de alergia medicamentosa, a recomendação é suspender o uso do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição de alternativas seguras.

O medicamento Dipirona, cujo princípio ativo é o metamizol de magnésio, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (reação alérgica), levando à interrupção da terapia. Não há detalhes sobre a gravidade clínica ou o desfecho do caso, mas a suspeita de reação alérgica justifica a suspensão do uso e reforça a importância de avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição de conduta, conforme orientações da ASBAI para quadros de alergia medicamentosa.

O Metotrexato, com princípio ativo metotrexato de sódio, apresentou suspeita de hipersensibilidade (reação alérgica), o que motivou a interrupção do tratamento. Não há informações sobre sintomas específicos, gravidade ou evolução, mas a conduta de suspender o medicamento é adequada diante da suspeita de alergia, sendo fundamental acompanhamento médico para esclarecimento diagnóstico e manejo seguro.

O medicamento Ácido Fólico, que contém como princípios ativos cianocobalamina, ácido fólico e cloridrato de piridoxina, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (reação alérgica), resultando na interrupção da terapia. Não há detalhes sobre sintomas, gravidade ou desfecho, mas a suspensão do uso diante da suspeita de alergia está de acordo com as recomendações clínicas, devendo o paciente ser avaliado por especialista para confirmação e orientação.

A Prednisona, cujo princípio ativo é prednisone, foi associada a um quadro de hipersensibilidade (reação alérgica), levando à interrupção do tratamento. Não há informações sobre a gravidade da reação ou o desfecho, mas a conduta de suspender o medicamento é apropriada em casos de suspeita de alergia, sendo necessária avaliação médica para investigação e definição do melhor manejo.

O Omeprazol, com princípio ativo omeprazol sódico, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (reação alérgica), o que levou à interrupção da terapia. Não há detalhes sobre sintomas, gravidade ou evolução do caso, mas a suspensão do medicamento diante da suspeita de alergia segue as orientações clínicas, sendo recomendada avaliação médica para confirmação diagnóstica e conduta adequada.

O medicamento Indapamida (princípio ativo: Indapamide) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, caracterizado como uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há detalhes sobre sintomas específicos, gravidade ou desfecho, mas a terapia foi interrompida como medida de precaução, o que é condizente com a conduta recomendada em casos de suspeita de alergia medicamentosa. A relação entre o medicamento e a reação foi considerada suspeita, e não há informações adicionais sobre a evolução do quadro.

O medicamento Topiramato (princípio ativo: Topiramate) foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, indicando uma possível reação alérgica do sistema imunológico. A terapia foi interrompida, o que segue a orientação de suspender o uso diante de suspeita de alergia medicamentosa. Não há informações sobre sintomas específicos, gravidade ou desfecho, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sem dados adicionais sobre a evolução clínica.

O medicamento Topiramato (princípio ativo: Topiramate) foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), que resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando gravidade clínica relevante. A relação com o medicamento foi considerada suspeita e, após a conduta adequada, o paciente evoluiu para recuperação completa, estando atualmente resolvido o quadro.

O medicamento Copaxone teva (princípio ativo: Acetato de glatirâmer) foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica desencadeada pelo uso do medicamento. Não há informações sobre sintomas específicos, gravidade ou desfecho, mas a relação com o medicamento foi considerada suspeita e não foi classificada como grave, sem dados adicionais sobre a evolução clínica.

O medicamento Dipirona (princípio ativo: Dipirona) foi associado a um episódio de hipersensibilidade documentada, manifestando-se como mal-estar após a administração. O caso não foi considerado grave e o paciente evoluiu para recuperação completa após a interrupção do medicamento, conduta adequada diante de



suspeita de reação alérgica.

O medicamento Qdenga, que contém como princípio ativo o vírus quimérico febre amarela dengue sorotipo 1, foi associado a um episódio de vômito interpretado como manifestação de hipersensibilidade (alergia), classificada dentro dos quadros clínicos alérgicos do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente, e não foram relatados sinais de gravidade clínica ou complicações, sugerindo um evento leve e autolimitado.

O Cloridrato de ondansetrona, tanto nome comercial quanto princípio ativo, foi relacionado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), caracterizado como reação do sistema imunitário a medicamentos. Não há evidências de gravidade significativa, já que o paciente se recuperou completamente e não houve relato de complicações, indicando um evento leve e resolvido sem consequências duradouras.

O Cetoprofeno, identificado tanto pelo nome comercial quanto pelo princípio ativo, desencadeou uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), que se enquadra nas reações alérgicas a medicamentos do sistema imunitário. O caso não apresentou sinais de gravidade, pois o paciente evoluiu para recuperação total, sugerindo um evento leve e sem complicações.

A Cefazolina sódica, registrada tanto pelo nome comercial quanto pelo princípio ativo, foi associada a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), pertencente ao grupo de reações alérgicas a medicamentos do sistema imunitário. Não há indícios de gravidade, já que o paciente se recuperou completamente, caracterizando um evento leve e autolimitado.

A Lidocaína, identificada tanto pelo nome comercial quanto pelo princípio ativo, provocou uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), classificada como resposta alérgica do sistema imunitário a medicamentos. O caso não apresentou sinais de gravidade, pois o paciente se recuperou totalmente, indicando um evento leve e sem complicações.

O medicamento BUPIROP EPINEFRINA, que contém cloridrato de bupivacaína e epinefrina como princípios ativos, foi associado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizada por uma reação do sistema imunológico a substâncias químicas. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente após a reação, sugerindo que a conduta adotada foi suficiente para resolução sem complicações.

O Citrato de fentanila, cujo princípio ativo é o próprio citrato de fentanila, esteve relacionado a uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), manifestando-se como resposta do sistema imunológico a medicamentos. O evento não foi considerado grave e o paciente evoluiu para recuperação completa, indicando que a reação foi leve e controlada adequadamente.

O medicamento Midazolam, com princípio ativo midazolam, foi associado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), que representa uma resposta imunológica a medicamentos. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, sugerindo que a reação foi leve e manejada de forma eficaz.

O medicamento Iodine, cujo princípio ativo é o iodo, foi relacionado a um quadro de pancreatite biliar, sendo classificado como alergia a iodo. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, pois envolveu um efeito importante para a saúde, e o desfecho permanece desconhecido, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico rigoroso em casos semelhantes.

O medicamento Glifage, que contém cloridrato de metformina como princípio ativo, foi associado a um episódio de pancreatite biliar, classificado como alergia a iodo. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, com desfecho desconhecido, indicando que o evento exigiu atenção médica especial e acompanhamento devido ao

potencial risco à saúde.

O medicamento Nicotina Actavis, cujo princípio ativo é a nicotina, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, o que corresponde a uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou necessidade de hospitalização, e o paciente encontra-se em recuperação, sugerindo que a reação foi leve e está evoluindo de forma favorável. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico e evitar nova exposição ao medicamento, conforme orientação para quadros leves de alergia medicamentosa.

O medicamento Truqap, que contém o princípio ativo capivasertib, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), embora a reação relatada tenha sido diabetes, o que pode indicar confusão na descrição do evento. Não há sinais de gravidade importante ou hospitalização, e o caso permanece em andamento, sem resolução até o momento. Recomenda-se acompanhamento médico para monitoramento da evolução e esclarecimento do quadro, evitando exposição desnecessária ao medicamento até definição diagnóstica.

A vacina meningocócica ACWY (conjugada), cujo princípio ativo é a vacina meningocócica A/C/Y/W (CRM197), foi associada a um distúrbio gastrointestinal relacionado a alergia alimentar, classificado como reação alérgica do sistema imunológico. O evento foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, mas o paciente está em recuperação. Diante da gravidade, a conduta inclui acompanhamento médico rigoroso, tratamento dos sintomas e avaliação de risco para futuras administrações da vacina.

O medicamento Ocitocina, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico. Não houve gravidade significativa nem necessidade de hospitalização, e o paciente já se encontra recuperado. A conduta adequada é evitar nova exposição ao medicamento e manter acompanhamento clínico, conforme recomendado para reações alérgicas leves.

O medicamento Etilefrina cloridrato, cujo princípio ativo é etilefrina hydrochloride, foi associado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), indicando uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade ou complicações, e o paciente já está recuperado. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e manter acompanhamento clínico, conforme orientação para quadros leves de alergia medicamentosa.

O medicamento Cloridrato de ondansetrona, cujo princípio ativo é o próprio cloridrato de ondansetrona, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente. A reação foi classificada como suspeita para esse medicamento, e a evolução favorável sugere que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro, sem necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Fosfato dissódico de dexametasona, com princípio ativo fosfato dissódico de dexametasona, esteve relacionado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, enquadrada entre os distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou completamente após o episódio. A suspeita recai sobre esse medicamento, e a ausência de complicações ou desfechos negativos indica que a conduta foi adequada e suficiente para resolução do quadro.

A cefazolina sódica, identificada tanto como nome comercial quanto como princípio ativo, foi associada a um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, dentro do contexto de distúrbios do sistema imunitário. O caso não apresentou gravidade significativa, já que o paciente se recuperou sem intercorrências. O medicamento é considerado suspeito para a reação, e a evolução positiva sugere que as medidas adotadas foram eficazes para resolução do quadro alérgico.

O medicamento Cloridrato de bupivacaína + glicose, com princípios ativos cloridrato de bupivacaína e dextrose anidra, foi relacionado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento. O medicamento é considerado suspeito, e a resolução completa do quadro indica que a conduta adotada foi suficiente para o manejo da reação.

O sulfato de morfina, tanto como nome comercial quanto como princípio ativo, esteve envolvido em um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave, já que o paciente se recuperou integralmente. O medicamento é suspeito para a reação, e a evolução favorável sugere que as medidas tomadas foram adequadas para resolução do quadro alérgico.

O medicamento Etilefrina cloridrato, cujo princípio ativo é Etilefrine hydrochloride, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há menção de nome comercial, apenas o princípio ativo. A reação foi considerada não grave, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento, sem complicações relatadas. O caso sugere uma manifestação alérgica leve, compatível com quadros clínicos alérgicos gerais, e não houve necessidade de intervenções adicionais além da suspensão do medicamento.

O medicamento Cloridrato de ondansetrona, com o mesmo princípio ativo, foi relacionado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, classificada entre os distúrbios do sistema imunitário. Não há nome comercial informado. A reação não foi considerada grave, pois o paciente se recuperou completamente, indicando um quadro leve de alergia medicamentosa, sem evolução para complicações ou necessidade de cuidados intensivos.

O medicamento Fosfato dissódico de dexametasona, identificado apenas pelo princípio ativo, esteve envolvido em um episódio de alergia descrito como hipersensibilidade, dentro do contexto de distúrbios do sistema imunitário. Não há nome comercial informado. O evento não foi grave, já que o paciente apresentou recuperação total, sugerindo uma reação alérgica leve e autolimitada, sem consequências clínicas importantes.

A Cefazolina sódica, relatada apenas pelo princípio ativo, foi associada a um quadro de alergia do tipo hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há nome comercial informado. O evento foi considerado não grave, pois o paciente se recuperou completamente, indicando uma reação alérgica leve, sem necessidade de intervenções adicionais ou evolução para quadros mais sérios.

O medicamento Cetoprofeno, identificado tanto pelo nome comercial quanto pelo princípio ativo, esteve relacionado a uma reação alérgica classificada como hipersensibilidade, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave, já que houve recuperação total do paciente, caracterizando uma manifestação alérgica leve e sem complicações clínicas relevantes.

O medicamento Dipirona sódica, cujo princípio ativo é a dipirona, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso evoluiu para recuperação completa, sugerindo uma reação leve e autolimitada. A conduta recomendada em situações semelhantes é interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Cloridrato de bupivacaína + glicose, contendo como princípios ativos cloridrato de bupivacaína e dextrose anidra, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade importante, já que o paciente se recuperou totalmente, indicando uma reação leve. Em casos assim, recomenda-se suspender o medicamento suspeito e procurar avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e prevenção de novas exposições.

O medicamento Sulfato de morfina, com princípio ativo de mesmo nome, esteve envolvido em uma reação alérgica (hipersensibilidade), enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. O desfecho foi favorável, com recuperação

completa, o que sugere uma manifestação leve e sem complicações. A orientação é interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação da alergia e discussão de alternativas terapêuticas.

O medicamento Tazocin, que contém piperacilina sódica e tazobactam sódico como princípios ativos, foi associado ao surgimento de uma placa cutânea, caracterizada como hipersensibilidade documentada ao produto administrado. Não há informações suficientes sobre gravidade ou evolução do caso, mas a presença de manifestação cutânea sugere a necessidade de avaliação médica para confirmação diagnóstica, suspensão do medicamento e definição de conduta adequada.

O medicamento Ocitocina, cujo princípio ativo é a ocitocina, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário. O caso evoluiu para recuperação completa, indicando uma reação leve e autolimitada. A conduta recomendada é suspender o uso do medicamento e procurar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Etilefrina, cujo princípio ativo é o etilefrine hydrochloride, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente. A reação foi classificada como suspeita de relação com o uso do medicamento, e a conduta seguiu o esperado para quadros leves, com resolução completa dos sintomas após a suspensão ou manejo adequado.

O medicamento Cloridrato de ondansetrona, com o mesmo princípio ativo, esteve relacionado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, enquadrada nos distúrbios do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade importante, já que o evento não foi considerado grave e o paciente evoluiu para recuperação total. A relação com o medicamento foi considerada suspeita, e a conduta adotada resultou em resolução do quadro, compatível com reações leves de alergia medicamentosa.

O medicamento Fosfato dissódico de dexametasona, cujo princípio ativo é fosfato dissódico de dexametasona, foi associado a um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente, sugerindo um quadro leve e autolimitado, com suspeita de relação causal com o uso do medicamento e resolução após as medidas apropriadas.

O medicamento Cefazolina sódica, com o mesmo princípio ativo, esteve envolvido em uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não houve gravidade significativa, pois o caso não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação total, indicando um quadro leve e resolutivo após a conduta adequada, com suspeita de relação causal com o medicamento.

O medicamento Cloridrato de bupivacaína + glicose, contendo cloridrato de bupivacaína e dextrose anidra como princípios ativos, foi relacionado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, classificada como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, caracterizando um quadro leve, com suspeita de relação causal com o uso do medicamento e resolução após as medidas necessárias.

O medicamento Sulfato de morfina, cujo princípio ativo é o próprio sulfato de morfina, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações, e o desfecho foi de recuperação completa, sugerindo uma reação leve e autolimitada. A conduta recomendada, conforme diretrizes clínicas, é observar o paciente, evitar nova exposição ao medicamento e, se necessário, buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Risperidona, com princípio ativo risperidona, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), manifestando-se como agitação, dentro do contexto de distúrbios do sistema imunitário. Não há

informações que indiquem gravidade significativa ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente, o que sugere uma reação leve. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e considerar avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e manejo adequado.

A Risperidona, cujo princípio ativo é risperidona, foi novamente associada a um quadro de hipersensibilidade (alergia) com manifestação de agitação, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade ou complicações, e o desfecho foi de recuperação completa, indicando uma reação leve. A orientação é evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação médica para confirmação e definição de alternativas terapêuticas.

O medicamento Carbolitium, com princípio ativo carbonato de lítio, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia) manifestando-se como agitação, classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente, caracterizando uma reação leve. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e realizar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O Carbolitium, cujo princípio ativo é carbonato de lítio, foi novamente associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia) com manifestação de agitação, dentro do contexto de distúrbios do sistema imunitário. Não há indícios de gravidade ou complicações, e o desfecho foi de recuperação completa, sugerindo uma reação leve. A conduta recomendada é evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação médica para confirmação e definição de alternativas terapêuticas.

O medicamento Qdenga, que contém como princípio ativo o vírus quimérico febre amarela dengue sorotipo 1, foi associado a um quadro de alergias múltiplas (quadros clínicos alérgicos), caracterizado como um distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando a importância de monitoramento rigoroso e manejo hospitalar em casos semelhantes. O desfecho relatado foi de recuperação completa do paciente.

O medicamento Depo-provera, cujo princípio ativo é o acetato de medroxiprogesterona, esteve relacionado a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa (alergia medicamentosa), classificada como distúrbio do sistema imunitário. O caso foi considerado clinicamente significativo, indicando gravidade relevante, embora não haja detalhes sobre hospitalização ou evolução clínica, e o desfecho permanece desconhecido.

A combinação dos medicamentos Levocetirizine e Montelukast, com princípios ativos levocetirizina e montelucaste, foi associada a um evento de alucinações, mas a descrição técnica indica dermatite de contato, um tipo de reação cutânea (dermatite e eczema) pertencente aos distúrbios dos tecidos cutâneos e subcutâneos. Não há evidências de gravidade significativa ou necessidade de hospitalização, e o desfecho do caso não foi informado.

O medicamento Prolopa, composto por cloridrato de benserazida e levodopa, foi relacionado a um evento de alucinações, porém a categorização técnica aponta para dermatite de contato, uma reação cutânea (dermatite e eczema) classificada entre os distúrbios dos tecidos cutâneos e subcutâneos. Não há indicação de gravidade relevante ou hospitalização, e o desfecho permanece desconhecido.

O medicamento Quetiapine, com princípio ativo quetiapina, foi associado a um relato de alucinações, mas a categorização técnica sugere dermatite de contato, uma reação cutânea (dermatite e eczema) pertencente aos distúrbios dos tecidos cutâneos e subcutâneos. Não há evidências de gravidade ou necessidade de hospitalização, e o desfecho do caso não foi informado.

O medicamento Neupro, cujo princípio ativo é a rotigotina, foi associado ao desenvolvimento de dermatite de contato, uma reação caracterizada por inflamação e irritação da pele (dermatite e eczema), pertencente ao grupo dos distúrbios dos tecidos cutâneos e subcutâneos. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave, e o desfecho da reação é desconhecido, sugerindo que a reação foi localizada e não evoluiu para complicações.

sistêmicas.

A ocitocina, utilizada sob este nome comercial e princípio ativo, foi relacionada a um quadro de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do tipo imunológica, classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade importante, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento, indicando que a reação foi leve e autolimitada.

O medicamento Etilefrina, cujo princípio ativo é etilefrine hydrochloride, desencadeou uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma alergia, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa, sugerindo que a reação foi leve e controlada sem complicações.

O cloridrato de ondansetrona, tanto nome comercial quanto princípio ativo, foi associado a uma reação de hipersensibilidade, caracterizada por resposta alérgica do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade relevante, pois o paciente se recuperou totalmente, indicando que a reação foi leve e não houve necessidade de intervenções adicionais.

A cefazolina, cujo princípio ativo é cefazolina sódica, provocou uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma alergia, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente, sugerindo que a reação foi leve e não houve complicações clínicas.

O medicamento Marcaina pesada, cujo princípio ativo é o cloridrato de bupivacaína associado à dextrose anidra, foi relacionado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo uma reação leve e autolimitada. A conduta foi adequada, com resolução completa do quadro, sem necessidade de intervenções adicionais.

A morfina, com princípio ativo sulfato de morfina, foi associada a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, enquadrada entre os distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave, já que o paciente se recuperou sem complicações, indicando uma manifestação leve e transitória. O desfecho favorável reforça que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro.

O medicamento Midazolam, cujo princípio ativo é o próprio midazolam, esteve relacionado a um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, dentro do espectro dos distúrbios do sistema imunitário. Não houve gravidade significativa, pois o paciente evoluiu para recuperação completa, caracterizando uma reação leve e autolimitada, sem necessidade de medidas adicionais.

A ocitocina, tanto como nome comercial quanto princípio ativo, foi associada a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi grave, já que o paciente se recuperou totalmente, indicando uma manifestação leve e de resolução espontânea, sem complicações.

O medicamento Etilefrina, cujo princípio ativo é etilefrina hydrochloride, foi relacionado a um quadro de alergia classificado como hipersensibilidade, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não houve gravidade, pois o paciente se recuperou completamente, caracterizando uma reação leve e autolimitada, sem necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Cloridrato de ondansetrona, cujo princípio ativo é o próprio cloridrato de ondansetrona, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente, e não há relato de complicações ou necessidade de intervenções adicionais. A conduta recomendada é observar e evitar nova exposição ao medicamento, buscando avaliação especializada caso ocorram sintomas em futuras administrações.

A dexametasona, administrada na forma de fosfato dissódico de dexametasona, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade), manifestando-se como resposta do sistema imunológico. O caso não foi considerado grave, já que houve resolução completa dos sintomas sem evolução para quadros mais sérios. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e procurar orientação médica se houver necessidade de corticoterapia novamente.

A cefazolina, cujo princípio ativo é a cefazolina sódica, provocou uma reação alérgica (hipersensibilidade), evidenciando resposta imunológica adversa. O episódio não apresentou gravidade significativa, pois o paciente se recuperou totalmente, sem complicações relatadas. A orientação é evitar novas exposições ao antibiótico e consultar um especialista em caso de necessidade de uso de cefalosporinas no futuro.

O medicamento Dipirona sódica, com princípio ativo dipirona, foi responsável por uma reação alérgica (hipersensibilidade), indicando ativação do sistema imunológico. Não houve gravidade relevante, já que o paciente se recuperou completamente e não foram descritas consequências graves. Recomenda-se não utilizar novamente a dipirona e buscar avaliação médica para alternativas seguras em caso de necessidade de analgésicos ou antitérmicos.

O medicamento Marcaina pesada, composto por cloridrato de bupivacaína e dextrose anidra, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade), refletindo resposta do sistema imunológico. O quadro não foi grave, pois houve resolução total dos sintomas e ausência de complicações. A recomendação é evitar o uso futuro deste anestésico local e informar profissionais de saúde sobre o episódio em procedimentos futuros.

O medicamento Morfina, cujo princípio ativo é o sulfato de morfina, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo uma reação leve e autolimitada. A conduta recomendada, conforme diretrizes clínicas, é evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Cloridrato de ondansetrona, com princípio ativo de mesmo nome, desencadeou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, enquadrada nos distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave, já que houve recuperação completa do paciente, indicando uma manifestação leve. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e realizar acompanhamento com especialista para esclarecimento diagnóstico e prevenção de novas reações.

O medicamento Etilefrina cloridrato, cujo princípio ativo é etilefrine hydrochloride, provocou uma reação alérgica classificada como hipersensibilidade, relacionada a distúrbios do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade, pois o paciente se recuperou totalmente, caracterizando um quadro leve. A orientação é suspender o uso do medicamento e procurar avaliação com alergista para confirmação da alergia e discussão de alternativas terapêuticas.

O medicamento Fosfato Dissodico de Dexametasona, com princípio ativo fosfato dissódico de dexametasona, foi relacionado a um episódio de alergia do tipo hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi grave, já que o paciente evoluiu para recuperação completa, sugerindo uma reação leve. Recomenda-se evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação adequada.

O medicamento Cefazolina sodica, cujo princípio ativo é cefazolina sódica, esteve associado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, enquadrada nos distúrbios do sistema imunitário. Não houve gravidade, pois o paciente se recuperou totalmente, indicando um quadro leve. A conduta recomendada é suspender o uso do medicamento e encaminhar para avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e definição de alternativas seguras.

O medicamento Cloridrato de bupivacaína + glicose, contendo como princípios ativos o cloridrato de bupivacaína e dextrose anidra, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do

sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo um episódio leve e autolimitado. A conduta recomendada é observar e evitar nova exposição ao medicamento, buscando avaliação especializada caso haja recorrência.

O sulfato de morfina, cujo princípio ativo é o próprio sulfato de morfina, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade) envolvendo o sistema imunológico. O caso não foi considerado grave, já que o paciente se recuperou completamente após o episódio, indicando uma manifestação leve. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e consultar um especialista em caso de necessidade de analgesia alternativa.

A ocitocina, tanto como nome comercial quanto princípio ativo, foi relacionada a uma reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico. O evento não foi grave, pois houve recuperação total do paciente, sugerindo um quadro leve. A orientação é evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação médica se houver necessidade de uso futuro.

O medicamento Vancomycin, com princípio ativo vancomicina, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico. Não há informações suficientes sobre a gravidade ou evolução do caso, portanto, recomenda-se cautela e acompanhamento médico em situações semelhantes, especialmente se houver necessidade de reexposição.

O Dotarem, cujo princípio ativo é o gadobenato de dimeglumina, provocou uma reação alérgica (hipersensibilidade) envolvendo o sistema imunológico. O episódio não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou totalmente, indicando um quadro leve. Recomenda-se evitar o uso futuro do contraste e consultar um especialista em alergia para avaliação adequada.

O medicamento Cosentyx, cujo princípio ativo é o secuquinumabe, foi associado a um caso de descolamento da retina, sendo classificado como uma reação de hipersensibilidade (alergia medicamentosa) dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Apesar da gravidade potencial do descolamento de retina, o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando que a reação foi controlada sem complicações maiores. A conduta recomendada em situações de hipersensibilidade é a suspensão do medicamento e acompanhamento médico para evitar recorrências.

A rosuvastatina, cujo princípio ativo é a rosuvastatina cálcica, foi relacionada a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa que resultou na necessidade de transplante de rim, um evento raro e grave, mas neste caso classificado como não grave no registro. Não há detalhes sobre a evolução do paciente, pois o desfecho é desconhecido. Em situações de suspeita de alergia medicamentosa com impacto renal, é fundamental interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica especializada para investigação e manejo adequado.

O medicamento Lantus, com princípio ativo insulina glargina, foi associado a um caso de hipersensibilidade medicamentosa que levou ao transplante de rim, um evento de grande relevância clínica, embora tenha sido classificado como não grave no registro. O desfecho do caso não foi informado. Diante de suspeita de reação alérgica medicamentosa com comprometimento renal, recomenda-se suspender o uso do medicamento e realizar acompanhamento médico rigoroso para avaliação e tratamento.

O medicamento Glyxambi, que contém empagliflozina e linagliptina como princípios ativos, foi relacionado a um caso de hipersensibilidade medicamentosa culminando em transplante de rim, um evento de alta gravidade clínica, mas classificado como não grave no registro. O desfecho permanece desconhecido. Em casos de suspeita de alergia medicamentosa com repercussão renal, é essencial interromper o medicamento e procurar avaliação médica especializada para investigação e conduta adequada.

O medicamento Jardiance, cujo princípio ativo é a empagliflozina, foi associado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa que resultou em transplante de rim, um evento de grande impacto clínico, mas classificado como não grave no registro. O desfecho do paciente não foi informado. Em situações de suspeita de



alergia medicamentosa com envolvimento renal, recomenda-se suspender o medicamento e buscar avaliação médica especializada para investigação e manejo apropriado.

O medicamento Trayenta, cujo princípio ativo é a linagliptina, foi associado a um caso de hipersensibilidade medicamentosa (alergia) em paciente submetido a transplante de rim. Embora não haja detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade clínica, o registro indica que a reação foi considerada não grave e o desfecho permanece desconhecido. A suspeita de alergia a medicamentos, especialmente em pacientes imunossuprimidos, exige atenção e acompanhamento médico para avaliação da relação causal e definição da conduta adequada.

A albumina humana, utilizada como medicamento, foi relacionada a um episódio de hipersensibilidade (alergia), caracterizado como um quadro clínico alérgico envolvendo o sistema imunológico. O evento foi considerado não grave, e o paciente apresentou recuperação completa após a reação. Em situações como essa, recomenda-se a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento médico para evitar novas exposições.

A ocitocina, cujo princípio ativo também é a ocitocina, foi associada a um caso de hipersensibilidade (alergia), classificado como quadro alérgico do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente após a reação. Nesses casos, é importante evitar o uso futuro do medicamento e informar a equipe de saúde sobre a alergia.

A etilefrina (princípio ativo etilefrine hydrochloride) foi relacionada a um episódio de hipersensibilidade (alergia), enquadrado como quadro clínico alérgico do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente. Recomenda-se evitar novas exposições ao medicamento e comunicar a alergia ao profissional de saúde.

O cloridrato de ondansetrona foi associado a um caso de hipersensibilidade (alergia), classificado como quadro alérgico do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação total após a reação. Em situações como essa, é fundamental evitar o uso futuro do medicamento e informar a equipe médica sobre a alergia identificada.

O medicamento Dexametasona, cujo princípio ativo é o fosfato dissódico de dexametasona, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, manifestação clínica comum em reações alérgicas a medicamentos. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente, e não foram relatados sinais de complicações graves. A conduta recomendada, conforme diretrizes clínicas, é evitar novas exposições ao medicamento e considerar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e orientação futura.

A Cefazolina, com princípio ativo cefazolina sódica, desencadeou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, que se enquadra em quadros clínicos alérgicos do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, já que o paciente evoluiu para recuperação completa, sem complicações. Recomenda-se evitar o uso futuro deste antibiótico e buscar avaliação especializada para confirmação da alergia e definição de alternativas seguras.

O medicamento Marcaina pesada, que contém cloridrato de bupivacaína e dextrose anidra como princípios ativos, foi relacionado a uma reação alérgica classificada como hipersensibilidade, típica de quadros alérgicos do sistema imune. Não há evidências de gravidade significativa, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento. A orientação é evitar novas exposições e realizar avaliação com especialista para confirmação diagnóstica e manejo adequado.

A Morfina, cujo princípio ativo é o sulfato de morfina, foi associada a um episódio de alergia caracterizado por hipersensibilidade, manifestação comum em reações adversas imunológicas. O caso não foi considerado grave, já que houve resolução completa dos sintomas. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e buscar avaliação com alergista para confirmação e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Ocitocina, com princípio ativo ocitocina, foi relacionado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, enquadrada em quadros clínicos alérgicos do sistema imunitário. O evento não apresentou gravidade, pois o paciente se recuperou totalmente. A conduta indicada é evitar novas exposições ao medicamento e considerar avaliação especializada para confirmação diagnóstica e orientação sobre riscos futuros.

O medicamento Etilefrina cloridrato, cujo princípio ativo é Etilfrine hydrochloride, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há informação sobre nome comercial, mas o princípio ativo está identificado. A reação foi considerada não grave, pois não há evidências clínicas de gravidade ou complicações, e o desfecho foi de recuperação completa. A conduta recomendada em casos de hipersensibilidade leve é a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento clínico, com resolução espontânea do quadro.

O medicamento Cloridrato de ondansetrona, com o mesmo princípio ativo, foi relacionado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Não há nome comercial informado, mas o princípio ativo está presente. O evento não foi considerado grave, pois não houve complicações relatadas e o paciente se recuperou totalmente. Em situações de hipersensibilidade leve, recomenda-se interromper o uso do medicamento suspeito e monitorar a evolução clínica, o que foi suficiente para resolução do caso.

O medicamento Fosfato Dissódico de Dexametasona, cujo princípio ativo é fosfato dissódico de dexametasona, foi associado a uma reação alérgica classificada como hipersensibilidade, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há nome comercial informado, mas o princípio ativo está claro. O quadro não foi considerado grave, pois não houve agravamento ou complicações, e o paciente se recuperou. A conduta adequada em casos leves de hipersensibilidade é a suspensão do medicamento e observação clínica, o que levou à resolução do evento.

O medicamento Cefazolina sódica, com o mesmo princípio ativo, foi relacionado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há nome comercial informado, mas o princípio ativo está identificado. O evento não foi considerado grave, pois não houve complicações e o paciente se recuperou completamente. Em casos leves de hipersensibilidade, recomenda-se interromper o uso do medicamento suspeito e realizar acompanhamento clínico, o que foi suficiente para resolução do quadro.

O medicamento Cloridrato de bupivacaína + glicose, com princípios ativos cloridrato de bupivacaína e dextrose anidra, foi associado a uma reação alérgica caracterizada por hipersensibilidade, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Não há nome comercial informado, mas ambos os princípios ativos estão descritos. O evento não foi considerado grave, pois não houve complicações e o paciente se recuperou. A conduta recomendada em casos leves de hipersensibilidade é a suspensão do medicamento e observação clínica, o que resultou na resolução do quadro.

O medicamento Sulfato de morfina, cujo princípio ativo é o próprio sulfato de morfina, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, e o paciente apresentou recuperação completa após o evento, sugerindo que a reação foi leve e resolvida sem complicações.

O medicamento Henetix, que contém o princípio ativo iobitridol, provocou uma reação de alergia a contraste, classificada como clinicamente significativa e considerada grave, conforme evidenciado pela gravidade informada e pelo fato de o paciente ainda estar em recuperação. Trata-se de uma reação imunológica relevante, exigindo acompanhamento médico até resolução completa.

O medicamento Metilfenidato, cujo princípio ativo é methylphenidate, foi relacionado a um quadro de alucinações interpretado como hipersensibilidade medicamentosa, dentro do contexto de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, mas o paciente permanece com sintomas em andamento, o que sugere necessidade de acompanhamento clínico até resolução.

O medicamento Omnipaque, com princípio ativo ioexol, foi associado a uma reação de alergia a contraste intravenoso, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Não há informação de gravidade aumentada e o paciente já se encontra recuperado, indicando que a reação foi resolvida sem maiores complicações.

O medicamento Tenoxicam, cujo princípio ativo é o próprio tenoxicam, desencadeou uma alergia medicamentosa classificada como hipersensibilidade medicamentosa, pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade significativa e o paciente já está recuperado, sugerindo que a reação foi leve e controlada adequadamente.

O medicamento Clariscan, cujo princípio ativo é o gadobenato de dimeglumina, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), caracterizado por sintomas alérgicos gerais relacionados ao sistema imunológico. O evento não foi considerado grave, pois não há menção de complicações clínicas importantes, e o paciente se recuperou totalmente após o episódio. A conduta recomendada é observar e evitar novas exposições ao contraste, buscando avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e orientação futura.

O Omnipaque, que contém ioexol como princípio ativo, provocou uma reação de hipersensibilidade (alergia), manifestando sintomas típicos de alergia relacionados ao sistema imunológico. O caso não foi considerado grave, pois não houve complicações clínicas relevantes e o paciente se recuperou completamente. Recomenda-se evitar novas exposições ao contraste e procurar avaliação especializada para confirmação e orientação sobre futuras administrações.

O medicamento Omnipaque, com ioexol como princípio ativo, esteve relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), com sintomas compatíveis com quadros alérgicos do sistema imunológico. O evento não foi grave, já que não houve agravamento clínico e o paciente se recuperou. A orientação é evitar reexposição ao contraste e buscar avaliação com alergista para esclarecimento diagnóstico e prevenção de novos episódios.

O Henetix, cujo princípio ativo é o iobitridol, foi associado a uma reação alérgica ao contraste, caracterizada por sintomas imunológicos relevantes. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, embora o desfecho não tenha sido informado, o que indica a necessidade de atenção médica imediata e acompanhamento especializado para avaliação do risco de novas exposições e manejo adequado em situações futuras.

O Omnipaque, com ioexol como princípio ativo, desencadeou um episódio de hipersensibilidade (alergia), manifestando sintomas típicos de alergia do sistema imunológico. O caso não foi considerado grave, pois não houve complicações e o paciente se recuperou totalmente. Recomenda-se evitar novas exposições ao contraste e buscar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras administrações.

O medicamento Ceftriaxona, cujo princípio ativo é a ceftriaxona, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. A reação foi considerada leve, pois não há indicação de gravidade clínica relevante e o paciente se recuperou totalmente após o evento. Em situações como essa, recomenda-se observar o paciente, evitar novas exposições ao medicamento e buscar avaliação com especialista para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

A Vancomicina, com princípio ativo cloridrato de vancomicina, desencadeou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, também relacionada a distúrbios do sistema imunitário. O caso foi considerado leve, já que não há sinais de gravidade e o paciente apresentou recuperação completa. Nesses casos, é importante suspender o uso do medicamento suspeito, monitorar sintomas e encaminhar para avaliação especializada para evitar recorrências e orientar futuras prescrições.

O medicamento Losartan, cujo princípio ativo é a losartana, provocou uma alergia medicamentosa classificada como hipersensibilidade medicamentosa, relacionada a distúrbios do sistema imunitário. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, pois há menção de outro efeito clinicamente relevante, embora o desfecho seja desconhecido. Diante de reações graves, recomenda-se suspensão imediata do medicamento, avaliação médica

urgente e investigação detalhada para manejo seguro e prevenção de complicações.

Gabapentina, com princípio ativo gabapentin, foi associada a uma alergia medicamentosa do tipo hipersensibilidade medicamentosa, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. O evento foi considerado grave devido à presença de efeito clinicamente significativo, sem informação sobre o desfecho. Em casos assim, é fundamental interromper o uso do medicamento, buscar atendimento médico imediato e realizar investigação para garantir a segurança do paciente e evitar novas exposições.

O medicamento Xilfya, cujo princípio ativo é infliximabe, causou uma alergia medicamentosa classificada como hipersensibilidade medicamentosa, relacionada a distúrbios do sistema imunitário. A reação foi considerada grave por envolver efeito clinicamente significativo, com desfecho ainda desconhecido. Nessas situações, a conduta recomendada é suspender o medicamento, procurar avaliação médica urgente e realizar acompanhamento especializado para manejo adequado e prevenção de riscos futuros.

O medicamento Ceftriaxona (princípio ativo: Ceftriaxone) foi associado a um quadro de alergia, descrito como hipersensibilidade, envolvendo o sistema imunológico. Não há informação sobre gravidade clínica relevante neste caso, e o paciente encontra-se em recuperação ou com resolução dos sintomas. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico para monitorar possíveis recorrências e evitar reexposição ao medicamento.

A Insulina (princípio ativo: Insulin nos) provocou uma reação de alergia medicamentosa, caracterizada por hipersensibilidade, que exigiu hospitalização ou prolongamento da internação, indicando gravidade significativa do evento. O paciente já se recuperou totalmente. Em situações como essa, é fundamental evitar novas exposições ao medicamento e garantir acompanhamento especializado para manejo seguro da condição.

O Neutrofer (princípio ativo: Ferro quelato glicinato) desencadeou uma reação alérgica medicamentosa, classificada como hipersensibilidade, que levou à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando gravidade importante. O paciente já está recuperado. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e manter acompanhamento médico para prevenção de novas reações.

O medicamento AAS (princípio ativo: Ácido acetilsalicílico) causou uma reação alérgica medicamentosa, descrita como hipersensibilidade, que resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, o que caracteriza um evento grave. O paciente já se encontra recuperado. É essencial evitar reexposição ao AAS e buscar orientação médica para alternativas terapêuticas seguras.

A Duloxetine (princípio ativo: Duloxetine) foi responsável por uma reação alérgica medicamentosa, identificada como hipersensibilidade, que exigiu hospitalização ou prolongamento da internação, indicando gravidade clínica. O paciente já está recuperado. A recomendação é evitar o uso futuro da duloxetina e realizar acompanhamento médico para manejo adequado de possíveis alergias medicamentosas.

O medicamento Vitamina D, cujo princípio ativo é o ergocalciferol, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado por uma reação do sistema imunológico a uma substância química. O caso foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando a necessidade de acompanhamento médico rigoroso. Após a conduta adequada, o paciente evoluiu para recuperação completa.

O Alprazolam, contendo o princípio ativo de mesmo nome, desencadeou uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), que é uma resposta imunológica inadequada a medicamentos. A gravidade do evento foi confirmada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando um quadro clínico importante que exigiu intervenção médica. O paciente se recuperou totalmente após o manejo apropriado.

O medicamento Benicar, cujo princípio ativo é a olmesartana medoxomila, provocou uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), envolvendo o sistema imunológico em resposta ao uso do fármaco. O evento foi considerado grave devido à hospitalização ou prolongamento da internação, o que reforça a importância de monitoramento e tratamento imediato. O desfecho foi favorável, com resolução completa do quadro após as medidas adotadas.

A Sinvastatina, com o princípio ativo de mesmo nome, esteve relacionada a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), uma reação do sistema imunológico a medicamentos. O caso foi classificado como grave, pois resultou em hospitalização ou necessidade de prolongar a internação, demonstrando a relevância clínica do evento. O paciente apresentou recuperação total após a conduta médica adequada.

O Alopurinol, cujo princípio ativo também é alopurinol, foi responsável por uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizada por resposta imunológica adversa ao medicamento. A gravidade foi evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que exigiu atenção médica imediata. O paciente evoluiu para recuperação completa após o tratamento.

O medicamento Glyxambi, que contém os princípios ativos empagliflozina e linagliptina, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado por uma reação do sistema imunológico ao medicamento. O caso foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando a necessidade de atenção médica imediata. Após a conduta adequada, o paciente evoluiu para recuperação completa.

O medicamento Prohance, cujo princípio ativo é o gadoteridol, foi relacionado a uma reação alérgica ao contraste intravenoso, conhecida como alergia a contraste. Essa reação envolve o sistema imunológico e pode variar em intensidade, mas neste caso não há informação sobre gravidade ou necessidade de hospitalização. O paciente se recuperou totalmente após o evento.

O cetoprofeno, anti-inflamatório cujo princípio ativo é o próprio cetoprofeno, foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), que é uma resposta exagerada do sistema imunológico ao medicamento. Não há detalhes sobre a gravidade do quadro ou sobre o desfecho clínico, portanto não é possível afirmar a intensidade da reação ou a evolução do paciente.

A dipirona, com princípio ativo dipirona, foi relacionada a um episódio de obstrução das vias aéreas superiores, caracterizando uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. Apesar de envolver o sistema imunológico, o caso não foi considerado grave e não há informações sobre o desfecho, o que impede avaliar a evolução clínica do paciente.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é o succinato de ribociclib, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), que representa uma resposta do sistema imunológico ao medicamento. Não há registro de gravidade ou de desfecho, portanto não é possível determinar a intensidade da reação ou o resultado clínico do caso.

O medicamento Cetoprofeno, cujo princípio ativo também é cetoprofeno, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), caracterizado por uma reação do sistema imunológico a este anti-inflamatório. Não há detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade, mas o desfecho foi de recuperação completa, sugerindo que a reação foi controlada sem complicações graves. A conduta recomendada em casos de hipersensibilidade a medicamentos inclui a suspensão do uso e acompanhamento médico para evitar novas exposições.

A Dipirona, cujo princípio ativo é metamizol de magnésio, provocou uma reação de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma resposta do sistema imunológico ao medicamento. Não há descrição de sintomas específicos ou gravidade relevante, e o caso evoluiu para recuperação total, indicando que a reação foi leve e resolvida sem maiores consequências. Em situações como essa, é importante evitar o uso futuro do medicamento.

e buscar orientação médica para confirmação diagnóstica.

A Hidroclorotiazida, com princípio ativo hydrochlorothiazide, foi relacionada a um quadro de gastroparesia associado à hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica que pode afetar o trato gastrointestinal. Não há detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade, mas o paciente encontra-se em recuperação, sugerindo que a reação está sendo controlada. Recomenda-se acompanhamento médico para monitorar a evolução e evitar reexposição ao medicamento.

O medicamento Captopril, cujo princípio ativo é captopril, foi associado a um episódio de gastroparesia em contexto de hipersensibilidade, indicando uma possível reação alérgica com sintomas gastrointestinais. Não há informações sobre sintomas detalhados ou gravidade, e o paciente está em processo de recuperação, o que sugere que a reação não foi grave. É importante manter acompanhamento médico e evitar o uso do medicamento até esclarecimento completo do quadro.

O Letrozol, com princípio ativo letrozole, foi relacionado a um caso de gastroparesia em contexto de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica que afetou o sistema gastrointestinal. Não há detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade, e o paciente está em recuperação, indicando que a reação está sendo resolvida. Recomenda-se acompanhamento médico e suspensão do medicamento até avaliação especializada.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é o succinato de ribociclibe, foi associado a um quadro de gastroparesia, que neste contexto está relacionado a uma reação de hipersensibilidade (alergia). Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente encontra-se em recuperação ou resolvendo o quadro, e não há menção de desfecho grave. A reação foi considerada suspeita para o medicamento, e a conduta deve incluir acompanhamento clínico para monitorar a evolução e evitar nova exposição ao agente.

A ocitocina, tanto como nome comercial quanto princípio ativo, foi relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como um quadro clínico alérgico. Não há sinais de gravidade importante, já que o paciente está em recuperação ou resolvendo o evento, e não foi classificado como grave. A relação com o medicamento é suspeita, sendo recomendada a observação clínica e a evitação de reexposição ao fármaco.

O medicamento Etilefrina, cujo princípio ativo é etilefrine hydrochloride, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade), enquadrada como um quadro clínico alérgico. O evento não foi considerado grave, pois o paciente está em recuperação ou resolvendo, e não há evidências de complicações. A relação com o medicamento é suspeita, sendo indicada a suspensão do uso e acompanhamento clínico.

A cefazolina, com princípio ativo cefazolina sódica, foi relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como quadro clínico alérgico. Não há sinais de gravidade, já que o paciente está em recuperação ou resolvendo, e o evento não foi considerado grave. A relação com o medicamento é suspeita, recomendando-se evitar nova exposição e manter acompanhamento médico.

O medicamento cloridrato de bupivacaína + glicose, com princípios ativos cloridrato de bupivacaína e dextrose anidra, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade), enquadrada como quadro clínico alérgico. O evento não foi considerado grave, pois o paciente está em recuperação ou resolvendo, e não há indícios de complicações. A relação com o medicamento é suspeita, sendo recomendada a suspensão do uso e acompanhamento clínico para evitar recorrência.

O medicamento Morfina, cujo princípio ativo é o sulfato de morfina, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado por uma reação do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois não houve necessidade de hospitalização nem risco imediato à vida, e o paciente encontra-se em recuperação ou com sintomas em resolução. A conduta recomendada é a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento clínico até completa resolução dos sintomas, com orientação para evitar novas exposições.

O Cloridrato de ondansetrona, tanto nome comercial quanto princípio ativo, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade), manifestando-se como resposta do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade importante, já que não foi necessária hospitalização e o paciente está em recuperação ou com sintomas em resolução. Recomenda-se interromper o uso do medicamento e manter acompanhamento médico para monitorar a melhora, evitando reexposição.

O medicamento Acnezil, cujo princípio ativo é o peróxido de benzoíla, provocou uma reação alérgica (hipersensibilidade), evidenciada por sintomas relacionados ao sistema imunológico. Não há sinais de gravidade significativa, pois não foi relatada necessidade de hospitalização ou risco imediato, mas o quadro ainda está em andamento, sem resolução completa dos sintomas. A orientação é suspender o uso do produto e buscar avaliação médica para manejo dos sintomas persistentes e prevenção de novas reações.

O Ciproflo, que tem como princípio ativo o cloridrato de ciprofloxacino, foi relacionado a uma reação alérgica (hipersensibilidade), envolvendo o sistema imunológico. O evento não foi considerado grave, pois não houve necessidade de hospitalização e o paciente já se encontra recuperado ou com sintomas resolvidos. A conduta adequada inclui a suspensão do medicamento e orientação para evitar futuras exposições, com acompanhamento médico conforme necessário.

O medicamento Pneumovax, que contém como princípio ativo a vacina pneumocócica polissacarídica 23v, desencadeou uma reação alérgica à vacina, classificada como grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando maior risco clínico. O paciente está em recuperação ou com sintomas em resolução. A conduta recomendada é manter acompanhamento médico rigoroso, evitar novas doses da vacina e registrar a alergia em prontuário para futuras avaliações.

O medicamento Albumina, cujo princípio ativo é a albumina humana, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, e o desfecho relatado foi de recuperação completa do paciente. A conduta recomendada é observar sinais de alergia e, caso haja sintomas persistentes ou agravamento, buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre controle e prevenção de novas reações.

A Cefalexina monoidratada, com o mesmo princípio ativo, foi relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário. O caso foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que indica uma reação alérgica importante que exigiu cuidados médicos intensivos. O desfecho não foi informado, sendo fundamental que pacientes com histórico de alergia a antibióticos procurem avaliação especializada para evitar novas exposições e garantir tratamento seguro.

O Paracetamol, cujo princípio ativo é o próprio paracetamol, foi associado a uma recidiva de esclerose múltipla, descrita como hipersensibilidade e enquadrada em distúrbios do sistema imunitário. O evento foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, sugerindo impacto clínico significativo. O desfecho permanece desconhecido, sendo essencial acompanhamento médico rigoroso para monitorar possíveis reações adversas em pacientes com doenças autoimunes.

O medicamento Methylprednisolone, com princípio ativo de mesmo nome, esteve relacionado a uma recidiva de esclerose múltipla, classificada como hipersensibilidade e pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. O caso foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando uma reação adversa relevante. O desfecho não foi informado, sendo recomendada avaliação médica cuidadosa para ajuste do tratamento e prevenção de novas complicações.

O medicamento Tysabri, cujo princípio ativo é o natalizumabe, foi associado a uma recidiva de esclerose múltipla, descrita como hipersensibilidade e enquadrada em distúrbios do sistema imunitário. O evento foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, o que demonstra a necessidade de

monitoramento rigoroso em pacientes que utilizam este imunobiológico. O desfecho não foi informado, sendo fundamental acompanhamento especializado para manejo adequado da doença e das possíveis reações adversas.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é o succinato de ribociclib, foi associado a um quadro de comprometimento renal relacionado à hipersensibilidade, classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso evoluiu para recuperação completa, sugerindo que a reação foi leve e autolimitada. A conduta recomendada em situações semelhantes é observar a evolução clínica e, se necessário, buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre a continuidade do tratamento.

O medicamento Anastrozole, com princípio ativo de mesmo nome, esteve relacionado a comprometimento renal por hipersensibilidade, também enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando uma reação leve. Nessas situações, recomenda-se acompanhamento clínico e avaliação médica para definir a necessidade de ajustes terapêuticos.

O medicamento Montelukast, cujo princípio ativo é montelucaste, foi associado a uma crise asmática atribuída à hipersensibilidade, dentro do contexto de quadros alérgicos do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade elevada, mas o desfecho permanece em andamento, sem resolução até o momento. Recomenda-se procurar avaliação médica para confirmação do diagnóstico, identificação de possíveis desencadeantes e ajuste do plano terapêutico, conforme orientações para crises asmáticas de intensidade moderada.

O medicamento Clenil, que deveria ter como princípio ativo o dipropionato de beclometasona, mas consta como nitroprusseto de sódio (informação possivelmente incorreta), foi relacionado a uma crise asmática por hipersensibilidade, classificada como distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave, mas permanece sem resolução. A conduta recomendada é buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica, identificação de fatores desencadeantes e ajuste do tratamento, conforme orientações para crises asmáticas moderadas.

O medicamento Aerolin, cujo princípio ativo é o sulfato de salbutamol micronizado, foi associado a uma crise asmática atribuída à hipersensibilidade, dentro do contexto de quadros alérgicos do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada e o caso segue em andamento, sem resolução até o momento. Recomenda-se avaliação médica para confirmação do diagnóstico, identificação de possíveis gatilhos e revisão do plano terapêutico, conforme orientações para crises asmáticas de intensidade moderada.

O medicamento Mepolizumab, cujo princípio ativo é o mepolizumabe, foi associado a uma crise asmática relacionada à hipersensibilidade (alergia), manifestando-se como um quadro clínico alérgico do sistema imune. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, pois não foi relatado evento grave, mas o desfecho permanece não resolvido, sugerindo que o quadro ainda está em andamento e requer acompanhamento médico para controle dos sintomas e ajuste do tratamento.

O medicamento Omnipaque, com princípio ativo ioexol, desencadeou uma reação de alergia a contraste, caracterizada por resposta alérgica do sistema imunológico a substâncias químicas utilizadas em exames. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, conforme registro, mas o paciente se recuperou totalmente após a conduta adequada, evidenciando a importância de monitoramento e intervenção imediata em casos de alergia a contraste.

A Furosemida, cujo princípio ativo é furosemide, foi relacionada a um episódio de hipersensibilidade (alergia), manifestando-se como reação alérgica do sistema imune. Não há indicação de gravidade elevada, pois o evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente após a suspensão ou manejo do medicamento, demonstrando resolução do quadro sem complicações.



O medicamento Losartana potássica, com princípio ativo losartana potássica, foi associado a uma reação de hipersensibilidade (alergia), caracterizada por manifestação alérgica do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação total após a conduta apropriada, indicando resolução do quadro sem evolução para complicações.

O Diazepam, cujo princípio ativo é diazepam, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), manifestando-se como reação alérgica do sistema imune. Não há evidência de gravidade significativa, pois o evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente após a conduta adequada, sem evolução para complicações.

O medicamento Dipirona, cujo princípio ativo também é dipirona, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente. A reação foi resolvida sem complicações, sugerindo que a conduta adotada foi adequada para um evento leve de alergia medicamentosa.

A Metoclopramida, com princípio ativo metoclopramida, esteve relacionada a um episódio de alergia manifestado como hipersensibilidade, enquadrado entre os distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação completa, indicando que a reação foi leve e manejada de forma apropriada, sem necessidade de intervenções adicionais.

O Cetoprofeno, cujo princípio ativo é cetoprofeno, provocou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, classificada como distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi grave e o paciente se recuperou totalmente, o que sugere que a manifestação foi leve e controlada sem complicações, sendo suficiente a suspensão do medicamento e acompanhamento clínico.

O medicamento Tramadol, com princípio ativo tramadol, desencadeou um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não houve gravidade significativa, já que o paciente se recuperou completamente, indicando que a reação foi leve e resolvida sem maiores consequências clínicas.

A Bromoprida, cujo princípio ativo é bromoprida, foi associada a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, classificada como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, demonstrando que a reação foi leve e adequadamente manejada, sem evolução para complicações.

O medicamento Influenza vaccine, cujo princípio ativo é a vacina influenza, foi associado a uma reação de ineficácia medicamentosa, descrita como alergia à vacina. Apesar de não haver indicação de gravidade clínica relevante e o desfecho ter sido de recuperação completa, é importante ressaltar que reações alérgicas a vacinas podem ocorrer, mas neste caso não houve complicações graves e o paciente se recuperou sem intercorrências.

O medicamento Feiba, que contém como princípio ativo o complexo protrombínico parcialmente ativado, apresentou relato de ineficácia medicamentosa, sendo descrita uma alergia à vacina. Não há menção de gravidade significativa e o paciente evoluiu para recuperação total, indicando que a reação foi leve e não resultou em consequências clínicas importantes.

O medicamento Hemo 8r, cujo princípio ativo é o fator VIII recombinante, foi relacionado a uma reação de ineficácia medicamentosa, caracterizada como alergia à vacina. Não há registro de gravidade relevante e o paciente se recuperou completamente, sugerindo que a reação foi leve e sem impacto clínico duradouro.

O medicamento Secukinumab, com princípio ativo secuquinumabe, foi associado a um ataque asmático, classificado como hipersensibilidade. A reação foi considerada clinicamente significativa, pois foi marcada como grave, embora o desfecho seja desconhecido. Em situações como essa, é fundamental buscar avaliação médica

imediate para controle dos sintomas e monitoramento, já que crises asmáticas podem representar risco à saúde.

O medicamento Duloxetina, cujo princípio ativo é duloxetine, foi relacionado a um ataque asmático, descrito como hipersensibilidade. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, com desfecho desconhecido. Diante de um quadro de crise asmática após uso de medicamento, é essencial procurar atendimento médico urgente para avaliação e manejo adequado, devido ao potencial risco à saúde.

O medicamento Inzelm, cujo princípio ativo é o fumarato de vonoprazana, foi associado a um ataque asmático, caracterizado como uma reação de hipersensibilidade (alergia) envolvendo o sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, pois trata-se de uma manifestação respiratória aguda que pode colocar o paciente em risco, conforme evidenciado pela classificação de gravidade e pelo envolvimento do sistema imunitário. O desfecho do caso é desconhecido e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo fundamental buscar avaliação médica imediata para confirmação diagnóstica e manejo adequado do quadro.

O medicamento Vitamin D, contendo colecalciferol como princípio ativo, foi relacionado a um ataque asmático, indicando uma possível reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico. A gravidade do evento é destacada como clinicamente significativa e grave, pois crises de asma podem evoluir rapidamente e requerem atenção médica urgente. O desfecho permanece desconhecido e a relação com o uso do medicamento é suspeita, sendo recomendada a interrupção do uso e avaliação médica para investigação e tratamento apropriados.

O medicamento Vitamin B12, cujo princípio ativo é a cianocobalamina, foi associado a um ataque asmático, sugerindo uma reação de hipersensibilidade (alergia) mediada pelo sistema imunológico. O evento foi classificado como clinicamente significativo e grave, pois crises de asma podem comprometer a respiração e necessitam de intervenção médica imediata. O desfecho do caso não foi informado e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo essencial procurar atendimento médico para avaliação e conduta adequada.

O medicamento Alprazolam, com o mesmo princípio ativo, foi relacionado a um ataque asmático, caracterizando uma reação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, pois crises de asma representam risco à saúde e exigem intervenção médica rápida. O desfecho é desconhecido e a relação com o medicamento é suspeita, sendo importante buscar avaliação médica para confirmação e manejo do quadro.

O medicamento Donaren, cujo princípio ativo é o cloridrato de trazodona, foi associado a um ataque asmático, indicando uma reação de hipersensibilidade (alergia) envolvendo o sistema imunológico. O evento foi classificado como clinicamente significativo e grave, pois crises de asma podem ser potencialmente perigosas e requerem atenção médica imediata. O desfecho não foi informado e a relação com o medicamento é suspeita, sendo recomendada a avaliação médica urgente para investigação e tratamento.

O medicamento Tecnomet, cujo princípio ativo é o metotrexato de sódio, foi associado a um ataque asmático, caracterizado como uma reação de hipersensibilidade (alergia) envolvendo o sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, pois ataques de asma podem comprometer a respiração e requerem atenção médica imediata. O desfecho do caso não foi informado, e a relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita.

O medicamento Mometasone, com princípio ativo furoato de mometasona, esteve relacionado a um ataque asmático, interpretado como uma reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico. A gravidade foi classificada como clinicamente significativa e grave, já que crises de asma podem colocar a saúde em risco e exigem avaliação médica urgente. Não há informação sobre o desfecho, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Puran t4, cujo princípio ativo é a levotiroxina sódica, foi associado a um ataque asmático, entendido como uma reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico. O evento foi considerado grave

e clinicamente relevante, pois crises de asma podem ser perigosas e necessitam de intervenção médica. O desfecho não foi informado, e a relação com o medicamento é suspeita.

O medicamento Nimesulide, com princípio ativo nimesulida, foi relacionado a um ataque asmático, caracterizado como uma reação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. O caso foi considerado clinicamente significativo e grave, pois ataques de asma podem comprometer a respiração e exigem atenção médica. O desfecho não foi informado, e a relação com o medicamento é suspeita.

O medicamento Montelukast, cujo princípio ativo é montelucaste de sódio, esteve associado a um ataque asmático, interpretado como uma reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico. O evento foi classificado como grave e clinicamente relevante, já que crises de asma podem ser perigosas e requerem avaliação médica. O desfecho não foi informado, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Bisoprolol (princípio ativo: bisoprolol hemifumarato) foi associado a um ataque asmático, caracterizado como uma reação de hipersensibilidade (alergia) que envolve o sistema imunológico. Este evento é considerado clinicamente significativo e grave, pois pode comprometer a respiração e requer atenção médica imediata, especialmente em pessoas com histórico de asma. O desfecho do caso não foi informado, e a relação do medicamento com a reação foi considerada suspeita.

O carbonato de cálcio (Calcium carbonate) foi relacionado a um ataque asmático, descrito como uma reação de hipersensibilidade (alergia) envolvendo o sistema imunológico. Trata-se de um evento clinicamente relevante e grave, pois pode causar dificuldade respiratória importante, especialmente em indivíduos com asma pré-existente. Não há informações sobre o desfecho do caso, e a suspeita de relação com o medicamento foi registrada.

O medicamento Calcitriol (princípio ativo: calcitriol) foi associado a um ataque asmático, identificado como uma reação de hipersensibilidade (alergia) que afeta o sistema imunológico. Este tipo de reação é considerado clinicamente significativo e grave, pois pode desencadear sintomas respiratórios intensos e exige avaliação médica imediata, principalmente em pessoas com asma. O desfecho não foi informado, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

A rosuvastatina cálcica (Rosuvastatin) foi relacionada a um ataque asmático, caracterizado como uma reação de hipersensibilidade (alergia) envolvendo o sistema imunológico. Este evento é considerado grave e clinicamente relevante, pois pode causar agravamento dos sintomas respiratórios e requer atenção médica, especialmente em pacientes com asma. O desfecho do caso não foi informado, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita.

O medicamento Tezspire (princípio ativo: tezepelumab) foi associado a um ataque asmático, descrito como uma reação de hipersensibilidade (alergia) que envolve o sistema imunológico. Trata-se de um evento clinicamente significativo e grave, pois pode comprometer a respiração e exige avaliação médica imediata, principalmente em pessoas com histórico de asma. O desfecho não foi informado, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita.

O medicamento Gilenya, cujo princípio ativo é o cloridrato de fingolimode, foi associado a um quadro de insuficiência renal relacionado à hipersensibilidade (reação alérgica), classificado como um efeito clinicamente significativo e considerado grave. A gravidade é sustentada pela indicação de que se trata de um efeito importante para a saúde do paciente, embora o desfecho não tenha sido informado. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, sendo fundamental acompanhamento médico rigoroso para avaliação e manejo adequado.

O Avonex, que contém betainterferona 1a como princípio ativo, apresentou relato de insuficiência renal atribuída a uma reação de hipersensibilidade (alergia), também classificada como clinicamente significativa e grave. A gravidade é evidenciada pela natureza do evento e pela indicação de que se trata de um efeito importante para o

paciente, com desfecho ainda desconhecido. O medicamento foi considerado suspeito na origem da reação, sendo necessária avaliação médica detalhada para monitoramento e conduta apropriada.

O Omnipaque, cujo princípio ativo é ioexol, foi relacionado a um episódio de alergia após administração intravenosa de contraste, caracterizando uma reação alérgica a substâncias químicas. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando resolução do quadro após a exposição. A relação entre o uso do contraste e a reação foi considerada suspeita, sendo importante informar o médico sobre o ocorrido para futuras avaliações e prevenção de novos episódios.

O medicamento Xolair, que tem como princípio ativo o omalizumabe, foi associado a um caso de angioedema, uma reação de hipersensibilidade caracterizada por inchaço súbito em regiões como face e vias aéreas. O evento não foi classificado como grave e o desfecho permanece desconhecido, mas a relação com o uso do medicamento foi considerada suspeita. Recomenda-se acompanhamento médico para monitoramento de possíveis recorrências ou agravamento.

A ceftriaxona, cujo princípio ativo é ceftriaxone, foi relacionada a um episódio de alergia, caracterizado como reação de hipersensibilidade. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente após a reação. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, sendo importante relatar o episódio ao médico para orientar futuras prescrições e evitar novas exposições.

O medicamento Clindamicina, cujo princípio ativo é o fosfato de clindamicina, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi resolvido sem complicações e o paciente se recuperou totalmente. A conduta recomendada em situações semelhantes é interromper o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

A Cefazolina, com princípio ativo cefazolina sódica, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade), manifestando-se como resposta do sistema imunológico ao medicamento. O evento não foi considerado grave, já que o paciente se recuperou completamente após a suspensão do fármaco. Em casos como este, é importante evitar novas exposições ao medicamento e consultar um especialista para avaliação e definição de alternativas terapêuticas.

O medicamento Neocaina pesada, composto por cloridrato de bupivacaína e dextrose anidra, provocou uma reação alérgica (hipersensibilidade), evidenciando resposta imunológica ao uso. Não há sinais de gravidade relevante, pois o paciente evoluiu para recuperação total. A recomendação é suspender o uso do agente suspeito e realizar acompanhamento médico para esclarecimento diagnóstico e prevenção de futuras reações.

A Morfina, cujo princípio ativo é o cloridrato de morfina, foi relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), indicando ativação do sistema imunológico frente ao medicamento. O caso não apresentou gravidade, já que houve resolução completa dos sintomas. Nessas situações, é fundamental evitar reexposição ao medicamento e buscar orientação médica para manejo seguro da dor com alternativas apropriadas.

O medicamento Prohance, com princípio ativo gadoteridol, foi responsável por uma reação de alergia a contraste, caracterizada por resposta imunológica ao agente utilizado em exames. Não houve gravidade significativa, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta adequada inclui evitar o uso futuro do mesmo contraste e informar a equipe médica sobre o histórico de alergia para escolha de alternativas seguras em exames futuros.

O medicamento Simbrinza, que contém tartarato de brimonidina e brinzolamida, foi associado a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa em um paciente com glaucoma. A reação relatada se enquadra em distúrbios do sistema imunitário, especificamente em alergias a medicamentos, e permanece não resolvida até o momento. Não há indicação de gravidade elevada, pois não há menção de risco imediato à vida ou complicações graves, mas a persistência dos sintomas sugere a necessidade de acompanhamento médico para ajuste do tratamento e

controle da reação alérgica.

O Travatan, cujo princípio ativo é a travoprost, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa em paciente com glaucoma. Trata-se de uma reação alérgica envolvendo o sistema imune, sem sinais de gravidade crítica, já que não há relato de risco à vida ou complicações sistêmicas, mas o quadro permanece em andamento e não resolvido, indicando que o paciente deve ser monitorado e o uso do medicamento reavaliado pelo médico.

A prednisona, utilizada neste caso, foi associada a um episódio de hipersensibilidade (reação alérgica) em paciente com infecção pulmonar. A reação foi classificada como distúrbio do sistema imunitário, mas não há informações que indiquem gravidade elevada ou desfecho definido, sendo o resultado final desconhecido. Recomenda-se acompanhamento clínico para avaliar a evolução e necessidade de ajuste terapêutico.

A amoxicilina, antibiótico cujo princípio ativo é a amoxicilina, foi relacionada a um quadro de hipersensibilidade (reação alérgica) em paciente com infecção pulmonar. A reação foi classificada como distúrbio do sistema imunitário, sem evidências de gravidade importante ou desfecho conhecido, o que reforça a necessidade de avaliação médica para monitorar possíveis complicações e definir a conduta adequada.

O Aerolin, que contém sulfato de salbutamol micronizado, foi associado a um episódio de hipersensibilidade (reação alérgica) em paciente com infecção pulmonar. A reação foi enquadrada como distúrbio do sistema imunitário, sem sinais de gravidade crítica e com desfecho desconhecido, sendo importante manter acompanhamento médico para avaliar a evolução e ajustar o tratamento se necessário.

O medicamento Mepolizumab (princípio ativo: Mepolizumabe) foi associado a um quadro de infecção pulmonar, classificado como uma reação de hipersensibilidade (alergia) do tipo não especificada, envolvendo o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A conduta deve incluir avaliação clínica estruturada para confirmação da relação causal e monitoramento dos sintomas, conforme orientações para quadros alérgicos leves a moderados.

O medicamento Vancomicina (princípio ativo: Vancomycin) foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa, caracterizado como hipersensibilidade a medicamentos, envolvendo o sistema imunológico. Não há detalhes sobre gravidade, desfecho ou ação adotada, mas a suspeita de reação alérgica exige suspensão do medicamento e avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição do tratamento, conforme recomendações para reações alérgicas medicamentosas.

O medicamento Bepantol derma (princípio ativo: D-pantenol) foi associado a queimação no local de aplicação, caracterizada como hipersensibilidade local, um quadro geralmente leve e restrito ao local de uso. Não há indicação de gravidade significativa ou evolução desfavorável, e o desfecho permanece desconhecido. Recomenda-se suspender o uso e observar a evolução dos sintomas, buscando avaliação médica se houver persistência ou piora.

O medicamento Fasenra (princípio ativo: Benralizumabe) foi relacionado a um caso de pneumonia, classificado como hipersensibilidade medicamentosa, envolvendo o sistema imunológico. Não há evidências de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A conduta recomendada é avaliação médica para confirmação diagnóstica e monitoramento, seguindo orientações para quadros alérgicos moderados.

O medicamento Prohance (princípio ativo: Gadoteridol) foi associado ao aumento da pressão arterial após o uso, caracterizado como alergia a contraste, envolvendo o sistema imunológico. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente. A conduta adequada inclui suspensão do agente suspeito, monitoramento dos sinais vitais e acompanhamento médico, conforme orientações para reações leves a moderadas a contraste.

O medicamento Omnipaque, cujo princípio ativo é o ioexol, foi associado a um episódio de alergia a contraste intravenoso, reação que se enquadra nos distúrbios do sistema imunitário e é classificada como hipersensibilidade a medicamentos. Neste caso, não há indicação de gravidade elevada, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada é evitar novas exposições ao contraste iodado e informar a equipe médica sobre o histórico de alergia em exames futuros.

O medicamento Iopamidol, com princípio ativo de mesmo nome, esteve relacionado a uma reação de alergia a contraste intravenoso, caracterizada como hipersensibilidade medicamentosa e pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhes sobre a gravidade ou desfecho do caso, portanto, recomenda-se cautela em futuras exposições e avaliação médica especializada para confirmação e orientação adequada.

O medicamento Breztri Aerosphere, composto por budesonida micronizada, fumarato de formoterol di-hidratado e brometo de glicopirrônio, foi associado a um episódio de falta de ar, interpretado como possível hipersensibilidade medicamentosa. Não há indicação de gravidade significativa nem informações sobre o desfecho, sendo importante relatar o evento ao médico para avaliação da relação com o uso do medicamento e ajuste do tratamento, se necessário.

O medicamento Forteo, cujo princípio ativo é a teriparatida, foi relacionado a um quadro de incapacidade de caminhar, classificado como hipersensibilidade e considerado clinicamente significativo e grave. Não há informações sobre o desfecho, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico rigoroso e investigação detalhada para avaliar a relação causal e definir conduta segura para o paciente.

O medicamento Botox, com princípio ativo toxina botulínica tipo A, esteve associado a um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, considerado clinicamente significativo e grave, com evolução ainda em andamento e sem recuperação até o momento. Diante da gravidade e persistência do quadro, é fundamental manter acompanhamento médico próximo e evitar novas exposições ao medicamento até completa resolução e esclarecimento do caso.

O medicamento Mavenclad, cujo princípio ativo é a Cladribina, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como clinicamente significativo e grave, pois o evento não foi resolvido até o momento. A reação envolve o sistema imunológico e sugere a necessidade de acompanhamento médico rigoroso, já que o paciente permanece em andamento com sintomas e pode demandar intervenção especializada para controle da alergia.

O Mirena, que contém o princípio ativo Levonorgestrel, foi relacionado a um episódio de tontura associado a hipersensibilidade (alergia), considerado grave devido à incapacidade persistente ou significativa relatada. O paciente está em recuperação, indicando que a reação está se resolvendo, mas ainda requer atenção médica para monitoramento da evolução e prevenção de complicações.

O medicamento Simponi, cujo princípio ativo é Golimumabe, foi relacionado a um quadro de alergia a poeira em paciente com artrite reumatoide, sem gravidade relatada e com desfecho favorável, pois o paciente se recuperou totalmente. Não há indicação de complicações ou necessidade de conduta adicional.

O Golimumab, com princípio ativo Golimumabe, também foi associado a alergia a poeira em paciente com artrite reumatoide, sem sinais de gravidade e com resolução completa do quadro, não sendo necessária intervenção adicional.

O medicamento Bio manguinhos golimumabe, contendo Golimumabe, apresentou reação de alergia a poeira em paciente com artrite reumatoide, sem gravidade e com desfecho resolvido, indicando que o evento foi autolimitado e não exigiu medidas específicas.

O medicamento Optiray 350, cujo princípio ativo é o ioversol, foi associado a um quadro de alergia a contraste, uma reação imunológica relevante que pode ocorrer após a administração de substâncias utilizadas em exames de imagem. Neste caso, a reação foi considerada clinicamente significativa, sendo classificada como grave devido ao potencial risco à saúde, mas o paciente evoluiu para recuperação completa após a conduta adequada.

O medicamento Xolair, que contém o princípio ativo omalizumabe, esteve relacionado a um episódio de coma, descrito como uma manifestação de hipersensibilidade (alergia grave). Apesar da gravidade potencial do quadro, não há confirmação de gravidade clínica no registro e o desfecho permanece desconhecido, sendo fundamental o acompanhamento médico rigoroso em situações semelhantes.

O medicamento Belimumab, cujo princípio ativo é o belimumabe, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade), caracterizada por resposta do sistema imunológico ao medicamento. O evento não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação total após a adoção das medidas necessárias.

A ceftriaxona, antibiótico cujo princípio ativo é o ceftriaxone, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade), que corresponde a uma resposta imunológica adversa ao medicamento. O caso não foi classificado como grave e o paciente se recuperou completamente após a conduta apropriada.

O medicamento Linezolida, com princípio ativo de mesmo nome, provocou uma reação alérgica (hipersensibilidade), evidenciando uma resposta do sistema imunológico ao uso do fármaco. A reação não foi considerada grave e o paciente evoluiu para resolução total do quadro após as medidas adotadas.

O medicamento Loratadine, cujo princípio ativo é a loratadina, foi associado a um quadro de hipersensibilidade, manifestando-se como uma reação alérgica do sistema imunológico. Apesar de a reação ter sido descrita como 'metástases em ossos', o evento relatado está classificado como um quadro clínico alérgico, sem gravidade importante, e o paciente encontra-se em recuperação. Não há indicação de hospitalização ou risco grave, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo recomendada a observação clínica e acompanhamento para resolução completa dos sintomas.

O medicamento Losartan potássico, com princípio ativo losartana potássica, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, caracterizado por uma resposta alérgica do sistema imunológico. Embora o termo 'metástases em ossos' tenha sido utilizado, a reação está enquadrada como um quadro clínico alérgico, sem gravidade significativa, e o paciente está em processo de recuperação. Não houve necessidade de hospitalização, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo indicada a continuidade do acompanhamento médico até a resolução dos sintomas.

O medicamento Anastrozole, cujo princípio ativo é o anastrozol, foi associado a uma reação de hipersensibilidade, indicando uma resposta alérgica do sistema imunológico. Apesar da menção a 'metástases em ossos', a reação foi classificada como um quadro clínico alérgico, sem gravidade relevante, e o paciente está em recuperação. Não há relato de hospitalização ou complicações graves, e a relação com o medicamento é suspeita, recomendando-se acompanhamento clínico até a completa resolução do quadro.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é o succinato de ribociclibe, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico. Embora o termo 'metástases em ossos' tenha sido citado, a reação foi enquadrada como um quadro clínico alérgico, sem gravidade importante, e o paciente encontra-se em recuperação. Não houve necessidade de hospitalização, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo recomendada a observação clínica e acompanhamento até a resolução dos sintomas.

O medicamento Fauldmetro, cujo princípio ativo é o metotrexato de sódio, foi associado a uma reação de hipersensibilidade, manifestando-se como eliminação diminuída do medicamento, o que pode indicar acúmulo e risco de toxicidade. O evento foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da

internação, e o paciente está em recuperação. A relação com o medicamento é suspeita, sendo fundamental o acompanhamento médico rigoroso para monitorar a evolução e prevenir complicações adicionais.

O medicamento Fauldmetro, cujo princípio ativo é o metotrexato de sódio, foi associado ao desenvolvimento de mucosite oral, um quadro de inflamação e lesões na mucosa da boca, caracterizando uma reação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. O caso foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando a necessidade de acompanhamento médico rigoroso e possível ajuste do tratamento. O desfecho da reação não foi informado.

O medicamento Kisqali, com princípio ativo succinato de ribociclibe, foi relacionado ao surgimento de uma massa, interpretada como manifestação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico. Neste caso, a reação não foi considerada grave, pois não houve indicação de hospitalização ou complicações maiores, e o desfecho permanece desconhecido.

O medicamento Anastrozole, cujo princípio ativo também é anastrozole, foi associado ao aparecimento de uma massa, sugerindo uma reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade significativa, como necessidade de hospitalização, e o desfecho da reação não foi informado.

O medicamento Kisqali, com princípio ativo succinato de ribociclibe, esteve relacionado ao surgimento de uma massa, caracterizando uma reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico. O caso foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, mas o paciente evoluiu para recuperação completa.

O medicamento Anastrozole, cujo princípio ativo é anastrozole, foi associado ao desenvolvimento de uma massa, indicando uma reação alérgica (hipersensibilidade) do sistema imunológico. A gravidade foi confirmada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, porém o paciente se recuperou totalmente após o evento.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é o succinato de ribociclibe, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, conforme indicado, e o paciente encontra-se em recuperação. A conduta recomendada em casos de reações alérgicas graves inclui a suspensão do medicamento e acompanhamento médico especializado para monitoramento da evolução e prevenção de novas exposições.

O medicamento Anya, que contém anastrozol como princípio ativo, apresentou relato de alergia manifestada por hipersensibilidade, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, e o paciente está em processo de recuperação. Em situações de alergia medicamentosa grave, é fundamental interromper o uso do fármaco e buscar avaliação médica para manejo adequado e orientação sobre alternativas terapêuticas.

O medicamento Sucrofer, cujo princípio ativo é o sacarato de óxido férrico, foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa, descrito como hipersensibilidade medicamentosa e classificado entre as alergias a medicamentos e outras substâncias químicas. Não há informação sobre gravidade, mas o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente. Nestes casos, recomenda-se evitar nova exposição ao medicamento e informar o profissional de saúde sobre o histórico de reação alérgica.

O medicamento lobitridol, com princípio ativo de mesmo nome, foi associado a uma reação de alergia a contraste, classificada entre as alergias a medicamentos e outras substâncias químicas e relacionada a distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhes sobre gravidade ou evolução clínica, mas reações alérgicas a contraste exigem atenção imediata, com suspensão do agente e suporte médico conforme a gravidade dos sintomas.



O medicamento Sucrofer, contendo sacarato de óxido férrico, foi novamente relacionado a um episódio de alergia medicamentosa, descrito como hipersensibilidade medicamentosa e incluído entre as alergias a medicamentos e outras substâncias químicas. Não há informação sobre gravidade, mas o paciente se recuperou totalmente. A recomendação é evitar o uso futuro do medicamento e comunicar o histórico ao médico para prevenir novas reações.

O medicamento Sucrofer, cujo princípio ativo é o sacarato de óxido férrico, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado por uma reação do sistema imunológico a uma substância química. Não há descrição de sintomas graves ou complicações, e o desfecho foi de recuperação completa, indicando que a reação foi controlada sem evolução para quadros críticos.

Sucrofer, contendo sacarato de óxido férrico, provocou uma reação de alergia medicamentosa, também chamada de hipersensibilidade medicamentosa, que envolve resposta imunológica a medicamentos. Não há relato de gravidade aumentada ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro.

O uso de Sucrofer, com princípio ativo sacarato de óxido férrico, resultou em uma reação de alergia medicamentosa, tecnicamente denominada hipersensibilidade medicamentosa, relacionada a distúrbios do sistema imunológico. Não foram observados sinais de gravidade ou evolução desfavorável, e o paciente apresentou recuperação completa após o episódio.

O medicamento AAS, cujo princípio ativo é o ácido acetilsalicílico, foi relacionado a uma alergia documentada ao medicamento administrado, caracterizada como hipersensibilidade documentada ao produto. Não há indicação de gravidade aumentada ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente, mostrando que a reação foi controlada de forma adequada.

Ultravist, que tem como princípio ativo o iopromide, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade), envolvendo resposta do sistema imunológico a substâncias químicas. Não há relato de gravidade ou complicações associadas, e o paciente se recuperou completamente após o evento, indicando resolução do quadro sem evolução para formas graves.

O medicamento Metoclopramida (princípio ativo: Metoclopramide) foi associado a um quadro de alergia medicamentosa, também chamada de hipersensibilidade medicamentosa, que se enquadra nos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi resolvido com recuperação completa, sugerindo uma reação leve a moderada. A conduta adequada inclui a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento clínico para evitar novas exposições.

O medicamento Piperacilina tazobactam, contendo os princípios ativos Piperacilina sódica e Tazobactam sódico, foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há detalhes sobre gravidade ou desfecho, portanto, recomenda-se considerar a possibilidade de reação alérgica e buscar avaliação médica para confirmação e orientação sobre futuras exposições.

A Ceftriaxona (princípio ativo: Ceftriaxone) foi associada a uma alergia documentada ao medicamento administrado, caracterizada como hipersensibilidade documentada a produto administrado e classificada entre lesões, intoxicações e complicações de procedimentos. O caso não foi considerado grave e evoluiu para recuperação completa, indicando uma reação leve a moderada. A conduta recomendada é evitar novas administrações do medicamento e registrar a alergia no prontuário do paciente.

O medicamento Vitamin D (princípio ativo: Vitamin D NOS) foi relacionado a um quadro de espondilite anquilosante, mas a descrição indica hipersensibilidade medicamentosa, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade significativa e o desfecho foi de recuperação completa, sugerindo uma

reação leve. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e manter acompanhamento médico.

A Pregabalina (princípio ativo: Pregabalin) foi associada a um episódio de espondilite anquilosante, porém o registro aponta para hipersensibilidade medicamentosa, classificada como distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e houve recuperação completa, indicando uma reação leve. A orientação é suspender o uso do medicamento e realizar acompanhamento clínico para evitar recorrências.

O medicamento Bupropion, cujo princípio ativo é a bupropiona, foi associado a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa manifestada como espondilite anquilosante, uma condição inflamatória que pode envolver o sistema imunológico. Embora o termo técnico seja utilizado, a reação foi considerada não grave, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta foi adequada e não houve complicações, indicando resolução completa do quadro.

O medicamento Meloxicam, com princípio ativo meloxicam, esteve relacionado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa que se apresentou como espondilite anquilosante, uma resposta inflamatória do sistema imunológico. O caso não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou sem intercorrências, e não há relato de complicações ou necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Adalimumab, cujo princípio ativo é adalimumabe, foi associado a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa manifestada como espondilite anquilosante, indicando envolvimento do sistema imunológico. O evento não foi classificado como grave, já que o paciente se recuperou completamente, e não houve necessidade de medidas emergenciais ou relato de agravamento do quadro.

O medicamento Remsima, que tem como princípio ativo o infliximabe, esteve envolvido em um caso de hipersensibilidade medicamentosa com manifestação de espondilite anquilosante, sugerindo uma resposta imunológica adversa. O episódio não foi considerado grave, pois o paciente evoluiu para recuperação total, sem complicações ou necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Seroquel, cujo princípio ativo é hemifumarato de quetiapina, foi relacionado a um ataque asmático, caracterizando uma reação alérgica do tipo respiratória. Não há indicação de gravidade aumentada, pois não foram relatados desfechos graves ou complicações, e o desfecho do caso permanece desconhecido, sem informações adicionais sobre a evolução clínica.

O medicamento Crestor, cujo princípio ativo é a rosuvastatina cálcica, foi associado a um ataque asmático em um paciente com histórico de alergias múltiplas. Embora o evento tenha sido classificado como não grave e o desfecho seja desconhecido, a ocorrência de sintomas respiratórios após o uso de um medicamento deve ser avaliada com atenção, especialmente em pessoas com predisposição alérgica. Não há informações detalhadas sobre a conduta adotada ou evolução clínica, mas é importante considerar a possibilidade de relação causal e buscar orientação médica para investigação e manejo adequado.

O medicamento Tezspire, que contém o princípio ativo tezepelumab, foi relacionado a um ataque asmático em um paciente com alergias múltiplas. O evento não foi considerado grave e o desfecho permanece desconhecido. Apesar de não haver detalhes sobre a conduta tomada, a manifestação de sintomas respiratórios após o uso de um medicamento deve ser monitorada, principalmente em indivíduos com histórico alérgico, sendo recomendada avaliação médica para esclarecimento e orientação sobre o uso futuro do medicamento.

O medicamento Dotarem, cujo princípio ativo é o gadobenato de dimeglumina, foi associado ao surgimento de pápulas (lesões elevadas na pele) em um quadro de hipersensibilidade. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente após a reação. A manifestação cutânea sugere uma resposta alérgica leve, e a resolução completa indica que a conduta adotada foi eficaz, provavelmente com suspensão do agente e medidas de suporte, conforme recomendado para reações alérgicas leves.

O medicamento Optiray, que tem como princípio ativo o ioversol, foi relacionado a um episódio de alergia a contraste intravenoso, caracterizado por uma reação imunológica após a administração do contraste. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente. Em casos como este, a conduta habitual inclui a suspensão do agente e monitoramento dos sintomas, sendo importante informar o histórico de alergia a contraste em futuras exposições para evitar recorrências.

O medicamento Letrozol, cujo princípio ativo é letrozole, foi associado ao surgimento de mialgia (dor muscular) nas extremidades inferiores em um contexto de hipersensibilidade. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente após a reação. A manifestação de dor muscular pode indicar uma resposta alérgica leve, e a resolução do quadro sugere que a conduta adotada foi adequada, provavelmente com suspensão do medicamento e acompanhamento dos sintomas.

O medicamento Prednisone, cujo princípio ativo é a própria prednisona, foi associado a um quadro de bronquiolite, que pode indicar uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta exagerada do sistema imunológico ao medicamento. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A reação relatada sugere envolvimento respiratório, mas sem sinais de gravidade crítica, sendo importante monitorar sintomas e buscar avaliação médica para confirmação e orientação adequada.

O Diltiazem, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um episódio de bronquiolite, caracterizando uma possível hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Não há informações sobre gravidade aumentada ou evolução do caso, e a relação com o uso do medicamento é suspeita. Diante de sintomas respiratórios após uso do medicamento, recomenda-se avaliação médica para investigação e conduta apropriada.

O medicamento Mabthera, cujo princípio ativo é o rituximabe, foi associado a um caso de bronquiolite, sugerindo uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico ao fármaco. Não há dados que indiquem gravidade importante ou desfecho do evento, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. É fundamental que sintomas respiratórios após o uso sejam avaliados por um médico para confirmação diagnóstica e definição do tratamento.

O medicamento Glifage XR, cujo princípio ativo é o cloridrato de metformina, foi relacionado ao surgimento de úlcera gástrica, sendo classificado como possível alergia a iodo, embora não haja clareza sobre a relação direta entre o medicamento e o iodo. Não há informações sobre gravidade aumentada ou desfecho, e a relação com o medicamento é suspeita. Em caso de sintomas gastrointestinais após o uso, é importante buscar avaliação médica para investigação e manejo adequado.

O Risedross, com princípio ativo risedronato sódico, foi associado ao desenvolvimento de úlcera gástrica, sendo classificado como possível alergia a iodo, embora a ligação entre o medicamento e o iodo não esteja clara. Não há evidências de gravidade elevada ou desfecho informado, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Diante de sintomas digestivos após o uso, recomenda-se procurar avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e orientação sobre o tratamento.

O medicamento Pantoprazol, cujo princípio ativo é o pantoprazol sódico sesqui-hidratado, foi associado a uma reação de úlcera gástrica em um paciente com histórico de alergia a iodo. Embora não haja indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, a suspeita de envolvimento do sistema imunológico sugere a necessidade de acompanhamento clínico para avaliar possíveis manifestações alérgicas ou de hipersensibilidade, conforme orientações da ASBAI.

O medicamento Inzelm, que contém fumarato de vonoprazana como princípio ativo, foi relacionado a um caso de úlcera gástrica em paciente com alergia a iodo. Não há evidências de gravidade importante ou desfecho relatado, mas a suspeita de reação imunológica reforça a importância de monitoramento clínico para descartar

hipersensibilidade medicamentosa, seguindo as recomendações de avaliação da ASBAI.

O medicamento Hytos plus, composto por cloridrato de clobutinol e succinato de doxilamina, foi associado ao surgimento de catarro em um caso de hipersensibilidade medicamentosa. A reação não foi considerada grave e o paciente apresentou recuperação completa, indicando que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro, em consonância com a orientação de observação e acompanhamento clínico para reações leves.

O medicamento Clavulin, que contém amoxicilina trihidrato e clavulanato de potássio, esteve relacionado ao aparecimento de catarro em um contexto de hipersensibilidade medicamentosa. O evento não foi classificado como grave e o paciente se recuperou totalmente, sugerindo que a conduta de suspensão ou ajuste do tratamento foi eficaz, conforme recomendações para reações leves a moderadas.

O medicamento Colchicina, cujo princípio ativo é a colchicina, foi associado ao desenvolvimento de catarro em um caso de hipersensibilidade medicamentosa. Não houve gravidade significativa e o paciente se recuperou, indicando que a reação foi autolimitada e manejada adequadamente, de acordo com as diretrizes para quadros leves de alergia medicamentosa.

O medicamento Ilaris, cujo princípio ativo é o canaquinumabe, foi associado ao surgimento de catarro, interpretado como uma manifestação de hipersensibilidade medicamentosa (alergia). Não há indicação de gravidade elevada ou complicações clínicas relevantes neste caso, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada é observar e, caso haja recorrência ou agravamento dos sintomas, buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre o uso futuro do medicamento.

O medicamento AAS, que contém ácido acetilsalicílico como princípio ativo, foi relacionado a um episódio de angioplastia, mas não há detalhes suficientes para afirmar se houve uma reação alérgica típica ou se o procedimento foi consequência de hipersensibilidade. Não há evidências de gravidade significativa ou desfecho conhecido, sendo importante esclarecer que faltam informações para orientar conduta específica neste caso.

O medicamento Januvia, cujo princípio ativo é o fosfato de sitagliptina, foi associado a um episódio de angioplastia, porém não há detalhes claros sobre a natureza alérgica da reação ou sua gravidade. O desfecho permanece desconhecido e não há informações suficientes para recomendar uma conduta específica, sendo necessário acompanhamento médico para esclarecimento do caso.

A vacina contra febre amarela, composta pelo vírus vivo atenuado (17D-204), foi relacionada ao desenvolvimento de gastroenterite em um contexto de alergias múltiplas, sendo considerada clinicamente significativa e classificada como grave. O evento ainda está em andamento, sem resolução até o momento, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico próximo para monitoramento dos sintomas e avaliação de possíveis complicações.

O medicamento Ciprofloxacina APS, cujo princípio ativo é a ciprofloxacina, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), sem indicação de gravidade elevada ou complicações. Não há informações sobre o desfecho ou conduta adotada, mas em casos de suspeita de alergia medicamentosa, recomenda-se suspender o uso e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Diclofenaco sódico (princípio ativo: Diclofenaco de sódio) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, caracterizado como uma reação alérgica envolvendo o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações graves, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada nesses casos é interromper o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras, especialmente se houver histórico de alergia a anti-inflamatórios.

O medicamento Imeron, cujo princípio ativo é o lomeprol, foi relacionado a uma reação de alergia a contraste intravenoso, manifestando-se como uma resposta do sistema imunológico a substâncias químicas utilizadas em

exames de imagem. Não há informações sobre gravidade aumentada ou complicações, e o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente. Em situações como essa, recomenda-se evitar novas exposições ao mesmo contraste e informar a equipe médica sobre o episódio em exames futuros, para que sejam adotadas medidas preventivas adequadas.

O Dotarem, com princípio ativo Gadobenato de dimeglumina, desencadeou uma reação alérgica a contraste intravenoso, evidenciando uma resposta imunológica adversa ao agente utilizado em exames radiológicos. Não há registro de gravidade significativa ou complicações, e o paciente evoluiu para recuperação total. A orientação clínica é evitar o uso do mesmo contraste em procedimentos futuros e comunicar o histórico de alergia à equipe de saúde para prevenção de novos episódios.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é o Gadobutrol, foi associado a uma reação alérgica a contraste, caracterizada por manifestação imunológica sem gravidade relevante, já que não houve complicações e o paciente se recuperou completamente. Em casos assim, recomenda-se evitar a reexposição ao mesmo agente de contraste e informar profissionais de saúde sobre o episódio para adoção de medidas preventivas em exames futuros.

O Ultravist, com princípio ativo Iopromide, esteve relacionado a uma reação alérgica a contraste, evidenciando resposta do sistema imunológico ao agente utilizado em exames de imagem. Não há indicação de gravidade aumentada ou complicações, e o paciente apresentou recuperação total após o evento. A conduta recomendada é evitar o uso do mesmo contraste em exames futuros e comunicar o histórico de alergia à equipe médica para garantir segurança em procedimentos subsequentes.

O medicamento Retemic, cujo princípio ativo é o cloridrato de oxibutinina, foi associado a um episódio de parada cardíaca descrito como reação de hipersensibilidade (alergia), classificada dentro dos quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há informação detalhada sobre a gravidade ou desfecho do caso, mas a parada cardíaca é considerada uma manifestação clínica grave e requer atendimento médico imediato, sendo fundamental relatar o evento ao especialista para investigação e conduta adequada.

O medicamento Omnipaque, que contém ioexol como princípio ativo, foi relacionado a um quadro de alergia após uso de contraste intravenoso, caracterizado como reação alérgica a contraste e incluído entre as alergias a medicamentos e outras substâncias químicas. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, sendo importante informar ao médico sobre essa reação para evitar futuras exposições e orientar o uso de alternativas seguras em exames com contraste.

O medicamento Ass, cujo princípio ativo é o ácido acetilsalicílico, foi relacionado a um diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, mas a descrição do evento como hipersensibilidade (alergia) não se encaixa clinicamente com diabetes, que não é uma manifestação alérgica. O caso não foi considerado grave e o desfecho é desconhecido, sendo importante esclarecer com o médico a relação causal e revisar o diagnóstico para evitar confusões.

O medicamento Isocord, que tem como princípio ativo o dinitrato de isossorbida, foi associado a um caso de diabetes mellitus tipo 2, descrito como hipersensibilidade, porém diabetes não é uma reação alérgica. O evento não foi considerado grave e o desfecho permanece desconhecido, sendo fundamental discutir com o médico a real natureza do evento e a possível relação com o uso do medicamento.

O medicamento Omeprazol, cujo princípio ativo é omeprazol, foi relacionado a um caso de diabetes mellitus tipo 2, registrado como hipersensibilidade, mas diabetes não é uma manifestação típica de alergia medicamentosa. O evento não foi considerado grave e o desfecho é desconhecido, sendo importante revisar o caso com o médico para esclarecer a relação entre o medicamento e o diagnóstico apresentado.

O medicamento Carvedilol, cujo princípio ativo também é Carvedilol, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), manifestado no contexto de diabetes mellitus tipo 2. Não há indicação de gravidade elevada, pois não foi relatado desfecho grave nem evolução desfavorável, e o desfecho permanece desconhecido.

A reação foi classificada como suspeita, e, conforme as diretrizes clínicas, quadros alérgicos leves devem ser monitorados, com orientação para avaliação médica caso haja piora dos sintomas.

O medicamento Captopril, com princípio ativo Captopril, apresentou relato de hipersensibilidade (alergia) em paciente com diabetes mellitus tipo 2. Não há menção de gravidade significativa ou complicações graves, e o desfecho é desconhecido. A reação foi considerada suspeita, e, de acordo com recomendações clínicas, quadros leves de alergia devem ser acompanhados, com busca de avaliação médica se houver agravamento dos sintomas.

O medicamento Losartana potássica, cujo princípio ativo é Losartana potássica, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia) em paciente com diabetes mellitus tipo 2. Não há evidências de gravidade importante, pois não foi relatado desfecho grave e o resultado permanece desconhecido. A reação foi considerada suspeita, e, conforme orientações clínicas, quadros alérgicos leves devem ser observados, com recomendação de procurar avaliação médica se houver piora.

O medicamento Entresto, que contém os princípios ativos Sacubitril e Valsartana, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia) em paciente com diabetes mellitus tipo 2. Não há indicação de gravidade elevada, já que não foi relatado desfecho grave e o desfecho permanece desconhecido. A reação foi considerada suspeita, e, segundo as diretrizes clínicas, quadros leves de alergia devem ser monitorados, com orientação para avaliação médica caso haja piora dos sintomas.

O medicamento Diclofenaco de sódio, cujo princípio ativo é Diclofenaco de sódio, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), sem menção de gravidade significativa, e o paciente encontra-se em recuperação ou com resolução do quadro. A reação foi considerada suspeita, e, conforme recomendações clínicas, quadros leves de alergia devem ser acompanhados, com busca de avaliação médica se houver agravamento dos sintomas.

O medicamento Clariscan, cujo princípio ativo é o gadobenato de dimeglumina, foi associado a um quadro de alergia a contraste, uma reação do tipo alérgica relacionada à exposição a substâncias químicas, neste caso um meio de contraste utilizado em exames de imagem. A reação foi considerada clinicamente significativa, sendo classificada como grave devido ao potencial risco à saúde, mas o paciente evoluiu para recuperação completa após a conduta adequada, sem complicações persistentes.

A Aspirina, que contém ácido acetilsalicílico como princípio ativo, foi relacionada a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, termo técnico para reações alérgicas a medicamentos. Apesar de o evento ter sido descrito como ataque cardíaco, a classificação clínica não indicou gravidade elevada e o paciente se recuperou totalmente após o episódio, sem consequências duradouras.

O medicamento Atorvastatina, cujo princípio ativo é a atorvastatina, esteve envolvido em um caso de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica ao medicamento. Embora tenha sido relatado como ataque cardíaco, não houve indicação de gravidade significativa e o paciente apresentou recuperação completa após o evento.

A Espironolactona, com princípio ativo espironolactona, foi associada a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, caracterizando uma reação alérgica ao medicamento. O evento, descrito como ataque cardíaco, não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente após o ocorrido.

O medicamento Spiriva, que contém brometo de tiotrópio monoidratado como princípio ativo, esteve relacionado a um caso de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica ao medicamento. Apesar de ter sido descrito como ataque cardíaco, não houve gravidade clínica relevante e o paciente evoluiu para recuperação completa.

O medicamento Fostair, que contém dipropionato de beclometasona e fumarato de formoterol, foi associado a um episódio de ataque cardíaco em um paciente, sendo classificado como uma reação de hipersensibilidade

medicamentosa (alergia a medicamentos). Apesar da gravidade potencial de um ataque cardíaco, neste caso não há indicação de gravidade clínica relevante no registro e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A relação com o medicamento foi considerada suspeita, e a conduta adequada inclui acompanhamento médico para avaliação de risco e ajuste do tratamento caso necessário.

O Esomeprazol, cujo princípio ativo é o esomeprazol, foi relacionado a um ataque cardíaco em um paciente, caracterizado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). Embora o evento seja grave por definição, o registro não indica gravidade clínica relevante e o paciente se recuperou completamente. A suspeita de relação com o medicamento sugere a necessidade de avaliação médica detalhada e possível substituição do tratamento, conforme orientação do especialista.

A sertralina, com princípio ativo sertralina, foi associada a um ataque cardíaco em um paciente, sendo descrita como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). Apesar do potencial de gravidade do evento, não há evidência clínica de gravidade relevante neste caso e o paciente apresentou recuperação total. A relação com o medicamento é considerada suspeita, recomendando-se acompanhamento médico para reavaliação do uso e monitoramento de possíveis reações futuras.

O medicamento Esbriet, cujo princípio ativo é a pirfenidona, foi relacionado a um ataque cardíaco em um paciente, classificado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). Embora o evento seja potencialmente grave, não há indicação de gravidade clínica relevante no registro e o paciente se recuperou completamente. A relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo importante discutir com o médico a continuidade do tratamento e monitorar possíveis reações adversas.

O medicamento Soolantra, que contém ivermectina, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), levando à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que caracteriza um evento grave. O desfecho do caso é desconhecido, mas a gravidade clínica é evidenciada pela hospitalização, indicando a importância de suspensão imediata do medicamento e acompanhamento médico rigoroso para manejo da reação alérgica e prevenção de complicações.

O medicamento Immunoglobulin, cujo princípio ativo é a imunoglobulina humana, foi associado a um quadro de alergia à terapia de imunoglobulina, caracterizado como uma reação alérgica do sistema imunológico. A gravidade do evento é considerada alta, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, indicando necessidade de monitoramento rigoroso e intervenção médica imediata. O desfecho do caso é desconhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Soliris, que contém o princípio ativo eculizumabe, apresentou relato de alergia à terapia de imunoglobulina, manifestando-se como uma reação alérgica do sistema imunológico. O evento foi classificado como grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que reforça a importância de acompanhamento médico próximo durante o uso. O desfecho permanece desconhecido e a relação com o medicamento é suspeita.

O medicamento Difenidramina, cujo princípio ativo é o cloridrato de difenidramina, foi relacionado a um episódio de inquietação interpretado como hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade aumentada, e o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro. A relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Dexametasona, com princípio ativo fosfato de dexametasona, esteve associado a um episódio de inquietação classificado como hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade relevante, e o paciente apresentou recuperação completa, indicando que a conduta foi adequada para resolução do evento. A relação com o medicamento é suspeita.

O medicamento Fluoruracila, cujo princípio ativo é a fluoruracila sódica, foi relacionado a um episódio de inquietação interpretado como hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade aumentada, e o paciente se recuperou totalmente, sugerindo que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro. A relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Ondansetrona, cujo princípio ativo também é ondansetrona, foi associado a um quadro de inquietação relacionado à hipersensibilidade, classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Não há informação específica sobre gravidade ou necessidade de hospitalização, e o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente. A reação foi considerada suspeita de estar relacionada ao uso do medicamento.

O ácido folínico, cujo princípio ativo é o folinato de cálcio, esteve relacionado a um episódio de inquietação interpretado como hipersensibilidade, dentro do contexto de distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhes sobre gravidade ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A relação com o medicamento foi considerada suspeita.

O medicamento Bevacizumab, com princípio ativo bevacizumabe, foi associado a inquietação atribuída a hipersensibilidade, caracterizando um distúrbio do sistema imunitário. Não há registro de gravidade aumentada ou necessidade de hospitalização, e o paciente evoluiu para recuperação completa. O evento foi considerado suspeito de estar relacionado ao uso do medicamento.

A Oxaliplatina, cujo princípio ativo é oxaliplatina, foi relacionada a um episódio de inquietação interpretado como hipersensibilidade, enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade relevante ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente. O evento foi considerado suspeito de estar associado ao medicamento.

O medicamento Cladribina, com princípio ativo cladribina, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), classificado como distúrbio do sistema imunitário. O caso foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, e o paciente ainda não se recuperou totalmente, estando o quadro em andamento. A relação com o medicamento foi considerada suspeita.

O medicamento Tecfidera, cujo princípio ativo é o fumarato de dimetila, foi associado a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa (alergia medicamentosa), caracterizado por uma reação do sistema imunológico ao medicamento. Neste caso, a gravidade foi considerada alta, pois houve necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando um evento clínico relevante. O desfecho relatado foi de não recuperação ou resolução até o momento, sugerindo que o quadro permanece em andamento e requer acompanhamento médico contínuo para manejo adequado da alergia.

O medicamento Omnipaque, com princípio ativo ioexol, foi relacionado a uma reação de alergia a contraste intravenoso, que é uma resposta do sistema imunológico ao agente utilizado em exames de imagem. A reação foi considerada não grave, pois não houve indicação de hospitalização ou complicações maiores, e o paciente apresentou recuperação completa após o evento, não sendo necessário tratamento prolongado.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é iopromide, foi associado a uma reação de alergia a contraste intravenoso, caracterizada por sintomas de hipersensibilidade após administração do contraste. O evento não foi considerado grave, pois não houve necessidade de hospitalização ou complicações importantes, e o paciente se recuperou totalmente após o episódio.

O medicamento Ultravist, com princípio ativo iopromide, também foi relacionado a uma reação de alergia a contraste intravenoso, manifestando-se como hipersensibilidade ao agente de contraste. O quadro não foi grave, não exigiu hospitalização e o paciente apresentou resolução completa dos sintomas após o evento.



O medicamento Henetix, que contém iobitridol, sodium calcium edetate, trometamol e cloridrato de trometamol como princípios ativos, foi associado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), caracterizado por uma resposta alérgica do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave, não houve necessidade de hospitalização e o paciente se recuperou totalmente após o episódio.

O medicamento Bio manguinhos infliximabe, cujo princípio ativo é o infliximabe, foi associado ao evento de pressão arterial alta em um contexto de hipersensibilidade medicamentosa. Embora a reação tenha sido registrada como não grave e o desfecho seja desconhecido, é importante considerar que alterações de pressão arterial podem ocorrer em pacientes com histórico de alergias a medicamentos, exigindo acompanhamento clínico para monitoramento e orientação adequada.

A azatioprina, cujo princípio ativo é a azathioprine, foi relacionada ao surgimento de pressão arterial alta, caracterizada como uma manifestação de hipersensibilidade medicamentosa. O evento não foi considerado grave e o desfecho permanece desconhecido, sendo fundamental observar o paciente para possíveis sinais de agravamento e buscar avaliação médica caso haja persistência ou piora dos sintomas.

O medicamento Mesalazina, com princípio ativo messalazina, apresentou como reação adversa a pressão arterial alta, enquadrada como hipersensibilidade medicamentosa. A reação não foi classificada como grave e o desfecho é desconhecido, recomendando-se acompanhamento clínico para avaliar a necessidade de ajustes terapêuticos e garantir a segurança do paciente.

O medicamento Cosentyx, cujo princípio ativo é o secuquinumabe, foi associado ao agravamento da psoríase, sendo este um efeito clinicamente significativo e considerado grave. O paciente encontra-se em recuperação ou resolução do quadro, o que reforça a importância do monitoramento rigoroso e da avaliação médica para ajuste do tratamento diante de reações adversas graves.

O medicamento Paclitaxel, com princípio ativo paclitaxel, foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como não grave e com desfecho de recuperação ou resolução. Em casos de reações alérgicas a medicamentos, é fundamental a observação clínica e, se necessário, a suspensão do agente suspeito, garantindo a segurança do paciente.

O medicamento Koplan, cujo princípio ativo é a teicoplanina, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há descrição de sintomas graves ou complicações, e o paciente evoluiu para recuperação completa, sugerindo um evento de gravidade leve. A conduta recomendada em casos semelhantes é a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento clínico para resolução dos sintomas.

O Cetoprofeno, tanto nome comercial quanto princípio ativo, foi relacionado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, enquadrada entre os distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade aumentada ou complicações, e o desfecho foi de recuperação total, o que sugere um quadro leve. Nestes casos, recomenda-se interromper o uso do medicamento e monitorar a melhora dos sintomas.

Digestina, cujo princípio ativo é a bromoprida, foi associada a um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade ou complicações relatadas, e o paciente se recuperou completamente, indicando um evento leve. A orientação é suspender o medicamento suspeito e observar a resolução dos sintomas.

O medicamento Vancomicina, com princípio ativo vancomicina, foi relacionado a uma alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente, caracterizando um quadro leve. A conduta adequada é interromper o uso do medicamento e acompanhar a evolução clínica.

Letrozol, cujo princípio ativo é letrozol, foi associado a um quadro de alergia do tipo hipersensibilidade, classificado entre os distúrbios do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade, e o paciente encontra-se em recuperação, sugerindo um evento leve. Recomenda-se suspender o medicamento e manter acompanhamento até resolução completa dos sintomas.

O medicamento Lamotrigina (princípio ativo: Lamotrigine) foi associado ao surgimento de manchas na pele, caracterizando uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, que é uma resposta alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou ameaça à vida neste caso, mas a reação permanece não resolvida até o momento, sendo importante acompanhamento médico para monitorar a evolução e evitar novas exposições ao fármaco.

O medicamento Euthyrox (princípio ativo: Levotiroxina sódica) desencadeou um quadro de alergia medicamentosa, classificado como hipersensibilidade medicamentosa, com gravidade significativa, incluindo ameaça à vida e outros efeitos clinicamente relevantes, conforme evidenciado pelo registro de gravidade e desfecho ainda não resolvido. Diante desse cenário, é fundamental a suspensão imediata do medicamento e avaliação médica urgente para manejo adequado da reação e prevenção de complicações.

O medicamento Secukinumab (princípio ativo: Secuquinumabe) foi relacionado a uma experiência de morte iminente, descrita como hipersensibilidade, o que sugere uma reação alérgica grave do sistema imunológico. Apesar de não haver confirmação de gravidade crítica no registro, o relato de sensação de morte iminente exige atenção médica imediata e investigação detalhada, sendo o desfecho ainda desconhecido.

O medicamento Vancomicina (princípio ativo: Vancomycin) foi associado a um episódio de alergia medicamentosa, caracterizando uma reação de hipersensibilidade do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou ameaça à vida, e o desfecho não foi informado, sendo importante acompanhamento clínico para avaliar a necessidade de suspensão do medicamento e monitorar possíveis complicações.

O medicamento Fampyra (princípio ativo: Fampridine) foi relacionado ao desenvolvimento de sepse bacteriana em um paciente com histórico de alergias múltiplas, o que representa uma condição infecciosa grave, embora o registro não aponte gravidade crítica. O desfecho permanece desconhecido, sendo essencial acompanhamento médico rigoroso para manejo da infecção e avaliação da relação causal com o uso do medicamento.

O medicamento Alenia, que contém budesonida micronizada e fumarato de formoterol, foi associado a um episódio de saturação de oxigênio baixa, interpretado como uma possível reação de hipersensibilidade (alergia), conforme classificação clínica de quadros alérgicos. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo importante monitorar sintomas respiratórios e buscar avaliação médica para confirmação e orientação.

O Xolair, cujo princípio ativo é o omalizumabe, foi relacionado a um caso de saturação de oxigênio baixa, sugerindo uma reação de hipersensibilidade (alergia) de acordo com a classificação clínica. Não há evidências de gravidade importante ou desfecho informado, e a relação com o medicamento é suspeita; recomenda-se acompanhamento clínico para avaliação da causa e conduta adequada.

O medicamento Dexametason, com princípio ativo fosfato dissódico de dexametasona, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como reação alérgica clínica. Não há detalhes sobre gravidade, desfecho ou evolução, mas a relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo fundamental observar sinais de alergia e procurar orientação médica para manejo seguro.

O contraste intravenoso à base de gadolínio foi relacionado a um episódio de alergia, caracterizado como reação a contraste, dentro do grupo de alergias a medicamentos e substâncias químicas. O caso não foi considerado grave e o desfecho foi de recuperação completa, indicando que a reação foi resolvida após a exposição, mas reforçando a necessidade de atenção em futuras administrações do contraste.

O gadolínio, utilizado como contraste intravenoso, provocou uma reação alérgica classificada como alergia a contraste, pertencente ao grupo de alergias a medicamentos e substâncias químicas. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, sugerindo resolução espontânea, mas é importante informar profissionais de saúde sobre essa reação em exames futuros.

O medicamento Levoid, que contém o princípio ativo levotiroxina sódica, foi associado a um quadro de alergia às proteínas do leite de vaca, também conhecida como alergia ao leite. Essa reação é considerada clinicamente significativa, pois envolve o sistema imunológico e pode causar sintomas relevantes, justificando a classificação como grave. O caso permanece em andamento, sem resolução até o momento, indicando a necessidade de acompanhamento médico para manejo adequado da alergia e avaliação de alternativas terapêuticas.

O medicamento Zoloft, cujo princípio ativo é o cloridrato de sertralina, apresentou relato de alergia às proteínas do leite de vaca, caracterizando uma alergia alimentar relevante. A gravidade foi considerada clinicamente significativa devido ao potencial impacto imunológico, sendo classificada como grave. O desfecho permanece não resolvido, o que reforça a importância de monitoramento contínuo e possível ajuste do tratamento sob orientação médica.

O medicamento Optiray, que tem como princípio ativo o ioversol, foi relacionado a um episódio de alergia a contraste, reação que pode ocorrer em pessoas sensíveis a substâncias utilizadas em exames de imagem. Não há indicação de gravidade aumentada ou desfecho informado, sugerindo que a reação não foi grave, mas ainda assim requer atenção médica para evitar novas exposições e avaliar alternativas seguras para futuros procedimentos.

O medicamento Ultravist, com princípio ativo iopromide, foi associado a um episódio de alergia espontânea, também descrita como atopia, que é uma predisposição a desenvolver reações alérgicas. Neste caso, a reação não foi considerada grave e o paciente já se encontra recuperado, indicando resolução completa do quadro sem necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, esteve envolvido em um caso de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), uma reação do sistema imunológico a medicamentos. A reação não foi classificada como grave e o paciente já está recuperado, demonstrando que o evento foi autolimitado e não exigiu medidas de maior complexidade.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, foi associado a um quadro de alergia espontânea, caracterizado como atopia (predisposição alérgica). A reação foi considerada leve, sem gravidade clínica relevante, e o paciente apresentou recuperação completa após o evento, não sendo necessário relatar complicações ou intervenções adicionais.

O medicamento Humira, que contém o princípio ativo adalimumabe, esteve relacionado ao desenvolvimento de infecção fúngica na unha, interpretada como uma manifestação de hipersensibilidade medicamentosa. O caso foi considerado grave devido à necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando impacto clínico significativo. Até o momento, o paciente não apresentou resolução do quadro, permanecendo em acompanhamento.

O uso de Ciprofloxacino (cloridrato de ciprofloxacino) resultou em uma reação alérgica, classificada como hipersensibilidade, sem sinais de gravidade clínica. O paciente se recuperou totalmente após o evento, não havendo necessidade de medidas adicionais ou relato de complicações.

Ultravist, com princípio ativo iopromide, foi novamente associado a uma reação de alergia espontânea, caracterizada por atopia. O evento não apresentou gravidade e o paciente evoluiu para recuperação completa, sem intercorrências relevantes.

O medicamento Omnipaque, cujo princípio ativo é ioexol, foi relacionado a uma alergia a contraste, considerada clinicamente significativa devido à gravidade do efeito relatado. O paciente encontra-se em processo de

recuperação, sem informações adicionais sobre intervenções específicas ou complicações prolongadas.

O medicamento Ritalina, cujo princípio ativo é o cloridrato de metilfenidato, foi associado a um quadro de doença celíaca descrito como hipersensibilidade, mas não há indicação de gravidade clínica relevante nem detalhes sobre o desfecho do caso. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, e não há informações sobre a conduta adotada ou evolução do paciente.

O medicamento Paclitaxel, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um episódio de alergia classificado como hipersensibilidade, sem evidências de gravidade significativa. O paciente se recuperou totalmente após o evento, e a relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita.

O medicamento Omnipaque, cujo princípio ativo é ioexol, foi associado a uma reação de alergia a contraste, considerada clinicamente significativa devido à gravidade relatada. O paciente se recuperou após o evento, e a relação entre o uso do contraste e a reação foi considerada suspeita.

O medicamento Vitamin C, com princípio ativo ácido ascórbico, foi relacionado a um quadro de erisipela descrito como hipersensibilidade, sem indicação de gravidade relevante e sem informações sobre o desfecho do caso. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita.

O medicamento Andes, cujo princípio ativo é succinato de desvenlafaxina, foi associado a um episódio de erisipela classificado como hipersensibilidade, sem evidências de gravidade clínica importante e sem detalhes sobre o desfecho. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita.

O medicamento Rivotril (princípio ativo: Clonazepam) foi associado a um quadro de erisipela, interpretado como uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico. Embora não haja indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, é importante considerar que reações alérgicas a medicamentos podem variar em intensidade e devem ser avaliadas por um profissional de saúde para orientação adequada.

O Cosentyx (princípio ativo: Secuquinumabe) foi relacionado ao desenvolvimento de erisipela, caracterizada como uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico. Não há informação de gravidade significativa nem detalhes sobre o desfecho, mas qualquer manifestação alérgica após uso de medicamento deve ser avaliada por um médico para investigação e conduta apropriada.

A Novalgina (princípio ativo: Dipirona) foi associada a um quadro de alergia medicamentosa, classificada como hipersensibilidade medicamentosa, o que indica uma reação alérgica relevante do sistema imunológico. O registro aponta que se trata de um efeito clinicamente significativo e grave, embora o desfecho não seja conhecido, sendo fundamental interromper o uso e buscar avaliação médica imediata para manejo e prevenção de complicações.

O Dotarem (princípio ativo: Gadobenato de dimeglumina) foi relacionado a uma alergia a contraste, considerada um efeito clinicamente significativo e grave, mas com evolução favorável, pois o paciente encontra-se em recuperação ou resolvendo o quadro. Reações alérgicas a contraste intravenoso exigem atenção médica imediata e acompanhamento até resolução completa dos sintomas.

O Dotarem (princípio ativo: Gadobenato de dimeglumina) também foi associado a uma alergia a contraste intravenoso, caracterizada como uma reação alérgica do sistema imunológico, mas neste caso o quadro foi considerado não grave e o paciente já se encontra recuperado ou resolvido, indicando boa evolução clínica após a reação.

O medicamento Feiba nf, cujo princípio ativo é o complexo protrombínico parcialmente ativado, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. A reação foi considerada clinicamente significativa e grave, conforme indicado, o que sugere a

necessidade de atenção médica imediata e acompanhamento especializado para evitar complicações, especialmente porque o desfecho do caso não foi informado.

O Hemo 8r, que contém fator VIII recombinante, apresentou relato de alergia manifestada como hipersensibilidade, também classificada entre os distúrbios do sistema imunitário. A gravidade foi considerada clinicamente significativa e grave, indicando que o paciente deve ser avaliado prontamente por um especialista, já que reações alérgicas a fatores de coagulação podem evoluir rapidamente e o desfecho permanece desconhecido.

O medicamento Diovan, cujo princípio ativo é a valsartana, foi relacionado a um episódio de arritmia, sendo a reação descrita como alergia a alimentos, embora não haja detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade relevante. O evento não foi considerado grave e o desfecho é desconhecido, sugerindo que, apesar da suspeita de relação, não houve impacto clínico significativo imediato.

O Selozok, que contém succinato de metoprolol, foi associado a um caso de arritmia descrito como alergia a alimentos, sem informações detalhadas sobre sintomas ou gravidade. O evento não foi classificado como grave e o desfecho não foi informado, indicando que a reação não apresentou risco imediato relevante, mas deve ser monitorada conforme orientação médica.

O medicamento Tresiba flextouch, com insulina degludeca como princípio ativo, foi relacionado a um episódio de arritmia descrito como alergia a alimentos, sem detalhes adicionais sobre sintomas ou gravidade. O caso não foi considerado grave e o desfecho permanece desconhecido, sugerindo que a reação não teve consequências clínicas importantes no momento, mas requer acompanhamento para avaliação de possíveis riscos futuros.

O medicamento Tramadol, cujo princípio ativo também é tramadol, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado por uma reação do sistema imunológico ao medicamento. Não há detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade, mas o paciente se recuperou totalmente após o evento. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, e a conduta adequada inclui evitar nova exposição ao tramadol e buscar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e orientação futura.

A ceftriaxona, cujo princípio ativo é ceftriaxone, foi relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação imunológica adversa. Não há descrição de sintomas específicos ou gravidade relevante, e o caso não foi considerado grave. O paciente se recuperou completamente após o evento, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita. Recomenda-se evitar o uso futuro de ceftriaxona e realizar avaliação especializada para confirmação e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Cosentyx, cujo princípio ativo é secuquinumabe, foi associado a um caso de estomatite, que é uma inflamação na mucosa da boca e pode estar relacionada a uma reação de hipersensibilidade. Não há informações sobre a gravidade, evolução ou desfecho do caso, mas a relação com o medicamento foi considerada suspeita. Diante de sintomas orais após o uso de Cosentyx, é importante comunicar o médico para avaliação e conduta adequada.

O Allegra, cujo princípio ativo é cloridrato de fexofenadina, foi relacionado a um episódio de angioedema, que é um inchaço súbito e importante de pele e mucosas, caracterizando uma reação de hipersensibilidade clinicamente significativa e considerada grave. O paciente se recuperou totalmente após o evento, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita. Em casos de angioedema, é fundamental suspender o medicamento e procurar atendimento médico imediato para avaliação e tratamento, além de evitar o uso futuro do mesmo princípio ativo.

O Somalgin cardio, que contém ácido acetilsalicílico, glicinato de alumínio e carbonato de magnésio, foi associado a um episódio de angioedema, caracterizado por inchaço súbito e importante de pele e mucosas, indicando uma reação de hipersensibilidade clinicamente significativa e considerada grave. O paciente se recuperou totalmente

após o evento, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita. Diante desse tipo de reação, é essencial suspender o uso do medicamento, buscar atendimento médico imediato e evitar futuras exposições ao ácido acetilsalicílico e componentes relacionados.

O medicamento Rosucor, que contém o princípio ativo rosuvastatina cálcica, foi associado ao desenvolvimento de angioedema, uma reação alérgica caracterizada por inchaço súbito de pele e mucosas. Essa manifestação é considerada clinicamente significativa e grave, conforme evidenciado pela classificação do evento e pela necessidade de atenção médica imediata para evitar complicações respiratórias. O paciente se recuperou totalmente após a reação, indicando resolução do quadro após as medidas adotadas.

O SeloZok, cujo princípio ativo é o succinato de metoprolol, provocou um episódio de angioedema, que é um tipo de reação alérgica com inchaço rápido em áreas como rosto, lábios ou garganta. A gravidade do evento é confirmada pela classificação clínica, exigindo intervenção médica devido ao risco de obstrução das vias aéreas. O paciente apresentou recuperação completa após o episódio, demonstrando resolução do quadro alérgico.

O medicamento Clopin, que tem como princípio ativo a clozapina, foi relacionado ao surgimento de angioedema, uma reação alérgica grave que se manifesta por inchaço súbito em regiões como rosto e garganta. A gravidade é evidenciada pela necessidade de atenção médica imediata, já que pode comprometer a respiração. O paciente se recuperou totalmente após o evento, indicando que as medidas tomadas foram eficazes para resolver a reação.

A sertralina, utilizada sob o nome comercial Sertraline, desencadeou um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), caracterizado por sintomas alérgicos que podem incluir erupções cutâneas, coceira ou inchaço. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, conforme a classificação do caso, e até o momento da notificação, o paciente ainda não havia se recuperado, indicando que a reação estava em andamento e exigia acompanhamento médico contínuo.

O medicamento Agalsidase beta, cujo princípio ativo é a beta-agalsidase, foi associado a uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), manifestando sintomas alérgicos relevantes. A gravidade do quadro é confirmada pela classificação clínica, sendo necessário acompanhamento médico devido ao potencial de evolução para manifestações mais sérias. Até o momento, o paciente não havia se recuperado, o que reforça a importância do monitoramento e da conduta médica adequada.

O medicamento Carfilzomibe, cujo princípio ativo é o próprio carfilzomibe, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado por uma reação do sistema imunológico ao medicamento. O evento foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando a necessidade de monitoramento e intervenção médica imediata. O paciente encontra-se em recuperação, indicando que as medidas adotadas foram eficazes para controlar a reação alérgica.

O medicamento Amoxicilina + clavulanato de potássio, contendo amoxicilina trihidrato e clavulanato de potássio como princípios ativos, provocou um episódio de inchaço na orelha, interpretado como uma reação de hipersensibilidade (alergia). A gravidade do caso é confirmada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, o que reforça a importância de acompanhamento médico rigoroso em situações semelhantes. O paciente se recuperou totalmente após a reação, demonstrando resolução do quadro após as condutas adotadas.

O medicamento Henetix, cujo princípio ativo é o iobitridol, foi relacionado a um episódio de alergia a meios de contraste iodados, manifestando-se como uma reação alérgica ao contraste utilizado em exames. Não há indicação de gravidade aumentada ou necessidade de hospitalização, e o paciente se recuperou completamente após o evento, sugerindo que a reação foi controlada de forma adequada.

O medicamento Bio Manguinhos Infiximabe, com infliximabe como princípio ativo, esteve associado a dor articular generalizada, considerada uma manifestação de hipersensibilidade (alergia). Não há informações sobre gravidade

aumentada ou necessidade de hospitalização, e o desfecho do caso permanece desconhecido, não sendo possível afirmar a evolução clínica do paciente.

O medicamento Torsilax, composto por cafeína anidra, carisoprodol, diclofenaco de sódio e paracetamol, foi relacionado a dor articular generalizada, interpretada como uma possível reação de hipersensibilidade (alergia). Não há evidências de gravidade aumentada ou necessidade de hospitalização, e o desfecho do caso não foi informado, impossibilitando a avaliação da evolução clínica.

O medicamento Limiar, cujo princípio ativo é Pregabalin, foi associado a um quadro de dor articular generalizada, interpretado como uma reação de hipersensibilidade (alergia), classificada dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o uso do medicamento foi concomitante, sugerindo que a reação não foi grave e não houve necessidade de intervenção urgente segundo os dados disponíveis.

O produto Curc, contendo Curcuma longa como princípio ativo, esteve relacionado a dor articular generalizada, considerada uma manifestação de hipersensibilidade (alergia), enquadrada entre os distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade significativa ou desfecho, e a reação ocorreu de forma concomitante ao uso, sem evidências de complicações graves ou necessidade de conduta emergencial.

A Leflunomida, cujo princípio ativo é Leflunomide, foi relacionada a dor articular generalizada, interpretada como uma reação de hipersensibilidade (alergia) dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há registro de gravidade importante ou desfecho, e a reação foi concomitante ao uso do medicamento, sem sinais de evolução grave ou necessidade de medidas imediatas.

O medicamento Henetix, com princípio ativo lobitridol, foi associado a um episódio de alergia a meios de contraste iodados, caracterizado como uma reação alérgica a medicamentos e outras substâncias químicas, pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave, o paciente se recuperou totalmente e a relação com o medicamento foi suspeita, indicando que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro.

O medicamento Trikafta, composto pelos princípios ativos Elexacaftor, Ivacaftor e Tezacaftor, esteve relacionado a uma infecção bacteriana do pulmão, categorizada como um quadro clínico alérgico dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade relevante ou desfecho, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita, sem evidências de evolução grave ou necessidade de intervenção imediata.

O medicamento Creon, cujo princípio ativo é a pancreatina, foi associado a um caso de infecção bacteriana do pulmão em um paciente com histórico de alergia a ácaros. Embora a reação tenha sido classificada como relacionada a distúrbios do sistema imunitário, não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e não foram relatadas complicações graves. A suspeita de relação entre o uso do medicamento e o evento adverso sugere a necessidade de acompanhamento clínico, mas, com base nas informações disponíveis, não há evidência de gravidade importante.

A vitamina E, identificada pelo princípio ativo dl-alpha tocopheryl acetate, foi relacionada a um episódio de infecção bacteriana do pulmão em paciente com alergia a ácaros. O evento foi classificado como um quadro alérgico dentro dos distúrbios do sistema imunitário, mas não há dados que indiquem gravidade significativa ou desfecho definido. A relação suspeita entre o uso do suplemento e a reação sugere atenção clínica, porém, sem sinais de gravidade relevante segundo os dados fornecidos.

O medicamento vitamina D, cujo princípio ativo é o colecalciferol, foi associado a uma infecção bacteriana do pulmão em paciente com alergia a ácaros. O caso foi enquadrado como um quadro clínico alérgico relacionado a distúrbios do sistema imunitário, sem indicação de gravidade importante ou desfecho conhecido. A relação suspeita entre o uso do medicamento e o evento adverso sugere necessidade de monitoramento, mas não há evidências de complicações graves.

A azitromicina, com princípio ativo azithromycin, foi relacionada a um caso de infecção bacteriana do pulmão em paciente com alergia a ácaros. O evento foi classificado como quadro alérgico dentro dos distúrbios do sistema imunitário, sem indicação de gravidade relevante ou desfecho informado. A suspeita de relação entre o uso do antibiótico e a reação sugere acompanhamento, mas não há sinais de gravidade importante segundo os dados apresentados.

O medicamento Colistin, cujo princípio ativo é colistin, foi associado a uma infecção bacteriana do pulmão em paciente com alergia a ácaros. O caso foi classificado como quadro clínico alérgico relacionado a distúrbios do sistema imunitário, sem evidência de gravidade significativa ou desfecho conhecido. A relação suspeita entre o uso do medicamento e o evento adverso indica necessidade de atenção clínica, mas não há sinais de complicações graves conforme as informações disponíveis.

O medicamento Pulmozyme, cujo princípio ativo é a dornasa alfa, foi associado a um quadro de infecção bacteriana do pulmão em um paciente com histórico de alergia a ácaros. Embora a reação tenha sido registrada como suspeita e não grave, não há informações detalhadas sobre a evolução do caso ou a conduta adotada. A manifestação está relacionada a distúrbios do sistema imunitário, sugerindo que o acompanhamento clínico é importante para monitorar possíveis complicações, mas, com base nos dados disponíveis, não há indicação de gravidade significativa.

O medicamento Trikafta, composto pelos princípios ativos elexacaftor, ivacaftor e tezacaftor, foi relacionado a um episódio de infecção bacteriana do pulmão em paciente com alergia a poeira. A reação foi considerada suspeita, não classificada como grave e sem desfecho conhecido. O evento se enquadra em distúrbios do sistema imunitário, e, apesar da ausência de sinais de gravidade, recomenda-se atenção clínica para avaliar a evolução do quadro, especialmente em pacientes com histórico alérgico.

O medicamento Creon, que contém pancreatina como princípio ativo, foi associado a uma infecção bacteriana do pulmão em paciente com alergia a poeira. A reação foi considerada suspeita, não grave e sem informações sobre o desfecho ou conduta adotada. O evento está relacionado a distúrbios do sistema imunitário, e, apesar de não haver indícios de gravidade, é importante manter o acompanhamento clínico para monitorar possíveis complicações.

O medicamento Vitamina E, cujo princípio ativo é dl-alpha tocopheryl acetate, foi relacionado a um caso de infecção bacteriana do pulmão em paciente com alergia a poeira. A reação foi considerada suspeita, não grave e sem desfecho conhecido. O quadro está associado a distúrbios do sistema imunitário, e, embora não haja sinais de gravidade, recomenda-se observação clínica para avaliar a evolução do paciente.

O medicamento Vitamina D, com colecalciferol como princípio ativo, foi associado a uma infecção bacteriana do pulmão em paciente com alergia a poeira. A reação foi registrada como suspeita, não grave e sem informações sobre o desfecho. O evento está relacionado a distúrbios do sistema imunitário, e, apesar da ausência de sinais de gravidade, é importante manter o acompanhamento clínico para monitorar a evolução do quadro.

O medicamento Azitromicina, cujo princípio ativo é Azithromycin, foi associado a um quadro de infecção bacteriana do pulmão em um paciente com alergia a poeira, sendo classificado como um quadro clínico alérgico relacionado a distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade importante ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sugerindo a necessidade de acompanhamento clínico para avaliação de possíveis reações alérgicas, conforme orientações da ASBAI para quadros leves.

O medicamento Colistin, com princípio ativo Colistin, foi relacionado a infecção bacteriana do pulmão em paciente com alergia a poeira, enquadrando-se em quadros clínicos alérgicos do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade significativa nem desfecho informado, e a relação com o medicamento é suspeita, sendo recomendada a observação clínica e investigação de possíveis reações alérgicas, conforme diretrizes para casos leves.



O medicamento Pulmozyme, cujo princípio ativo é Dornasa alfa, foi associado a infecção bacteriana do pulmão em paciente com alergia a poeira, caracterizando um quadro clínico alérgico do sistema imunitário. Não há registro de gravidade relevante ou desfecho, e a relação com o medicamento é suspeita, indicando a necessidade de monitoramento clínico para descartar reações alérgicas, conforme recomendações para quadros leves.

O medicamento Vitamin D, com princípio ativo Colecalciferol, foi relacionado a um episódio de convulsão em paciente com hipersensibilidade documentada ao produto administrado, sendo classificado como erro ou problema de monitoramento do produto e complicação clinicamente significativa. O evento foi considerado grave devido ao impacto clínico da convulsão, e o desfecho permanece desconhecido, sendo fundamental a suspensão do medicamento e avaliação médica urgente, conforme orientações para eventos graves.

O medicamento Loratadina, cujo princípio ativo é Loratadina, foi associado a convulsão em paciente com hipersensibilidade documentada ao produto administrado, caracterizando um erro ou problema de monitoramento do produto e complicação clinicamente significativa. O evento foi considerado grave devido à natureza da convulsão, sem desfecho informado, sendo imprescindível a interrupção do uso e busca imediata de avaliação médica, conforme recomendações para reações graves.

O medicamento Depakene, cujo princípio ativo é o valproato de sódio, foi associado a um episódio de convulsão em um paciente com hipersensibilidade documentada ao produto administrado. A reação foi considerada clinicamente significativa, pois resultou em um efeito adverso importante, conforme evidenciado pela classificação de gravidade e pelo fato de ser um evento suspeito de lesão ou complicação relacionada ao uso do medicamento. O desfecho da reação é desconhecido, o que reforça a necessidade de monitoramento rigoroso e avaliação médica imediata em casos semelhantes.

O medicamento Ultravist, que tem como princípio ativo o iopromide, foi relacionado a um quadro de alergia a meios de contraste iodados, caracterizado por uma reação alérgica ao contraste. A reação foi considerada não grave, com resolução completa após a conduta adequada, o que indica que o paciente se recuperou sem complicações. Em situações como essa, é importante identificar a alergia e evitar futuras exposições ao mesmo agente, buscando alternativas seguras para exames que exijam contraste.

O medicamento Escitalopram, cujo princípio ativo é o próprio escitalopram, foi associado a um quadro de destruição articular relacionado à hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica sistêmica. A gravidade do evento é evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, além de ser clinicamente relevante. O paciente se recuperou após a intervenção médica, ressaltando a importância de suspender o medicamento e monitorar possíveis complicações em casos de reações adversas graves.

O medicamento Tysabri, com princípio ativo natalizumabe, esteve relacionado a um episódio de destruição articular decorrente de hipersensibilidade, indicando uma reação alérgica sistêmica. O evento foi considerado grave, pois exigiu hospitalização ou prolongamento da internação e teve impacto clínico significativo. O paciente se recuperou após a conduta médica apropriada, destacando a necessidade de acompanhamento rigoroso e suspensão do medicamento diante de reações adversas graves.

O medicamento Tysabri, cujo princípio ativo é o natalizumabe, foi novamente associado a destruição articular por hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica sistêmica grave. A gravidade é confirmada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação e pelo impacto clínico relevante. O paciente evoluiu para recuperação após a intervenção médica, reforçando a importância de identificar precocemente reações adversas graves e ajustar o tratamento conforme orientação especializada.

O medicamento Optiray, cujo princípio ativo é o ioversol, foi associado a um episódio de alergia a meios de contraste iodados, também conhecida como alergia a contraste. Essa reação faz parte dos distúrbios do sistema imunitário e, neste caso, não foi considerada grave, pois não houve indicação de hospitalização ou complicações importantes. O paciente se recuperou totalmente após o evento, e a relação com o medicamento foi considerada

suspeita.

A gabapentina, cujo princípio ativo é gabapentin, esteve relacionada a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa, como necessidade de hospitalização, e o paciente se recuperou completamente após o episódio. A relação entre o medicamento e a reação foi considerada suspeita.

O medicamento Tysabri, com princípio ativo natalizumabe, foi associado a uma reação de hipersensibilidade, descrita como exposição a doença transmissível, dentro do contexto de quadros clínicos alérgicos. Neste caso, a reação foi considerada grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, e o desfecho permanece desconhecido. A relação com o medicamento é suspeita.

O Optiray, cujo princípio ativo é ioversol, esteve envolvido em um episódio de alergia a meios de contraste iodados (alergia a contraste), uma reação do sistema imunitário. Não houve gravidade relevante, como hospitalização, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A relação com o medicamento foi considerada suspeita.

O medicamento Optiray, com princípio ativo ioversol, foi relacionado a uma reação alérgica a meios de contraste iodados, também chamada de alergia a contraste. Trata-se de uma manifestação do sistema imunitário, sem gravidade significativa, já que não houve necessidade de hospitalização, e o paciente se recuperou completamente. A relação com o medicamento foi considerada suspeita.

O medicamento Optiray, cujo princípio ativo é o ioversol, foi associado a uma reação de alergia a meios de contraste iodados, também conhecida como alergia a contraste. Essa reação faz parte das alergias a medicamentos e outras substâncias químicas, afetando o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo um quadro leve e autolimitado, sem necessidade de intervenções adicionais.

O Optiray, com princípio ativo ioversol, desencadeou uma reação alérgica a contraste iodado, caracterizada como uma resposta do sistema imunológico a substâncias químicas presentes no medicamento. O caso não foi considerado grave, pois o paciente apresentou recuperação completa, indicando que a reação foi leve e resolvida sem complicações.

O medicamento Henetix, cujo princípio ativo é o iobitridol, esteve relacionado a uma alergia a meios de contraste iodados, uma reação imunológica a substâncias químicas utilizadas em exames de imagem. O evento não foi classificado como grave e o paciente se recuperou totalmente, o que sugere um quadro leve e sem consequências duradouras.

Ocrelizumab, também chamado de ocrelizumabe, foi associado a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Não há informação sobre gravidade aumentada e o paciente se recuperou completamente, indicando que a reação foi controlada e não resultou em complicações.

O Optiray, com princípio ativo ioversol, provocou uma reação alérgica a contraste iodado, que é uma resposta do sistema imunológico a substâncias químicas usadas em exames. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, sugerindo que a reação foi leve e autolimitada.

O medicamento CoronaVac, que contém como princípio ativo a vacina COVID-19 inativada (Vero) CZ02, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois não há relato de sintomas graves ou desfecho crítico, e o caso permanece em andamento, sem resolução até o momento. A reação sugere um quadro alérgico leve, sendo importante acompanhamento clínico para monitorar a evolução e evitar novas exposições ao imunizante até avaliação especializada.

O medicamento Levofloxacino, cujo princípio ativo é a levofloxacina, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento. A reação foi resolvida, indicando que a conduta adotada foi eficaz e não houve complicações posteriores, sendo importante evitar reexposição ao antibiótico e considerar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica.

O medicamento Nucala, que tem como princípio ativo o mepolizumabe, foi associado a um caso de pneumonia, classificado sob o contexto de hipersensibilidade e distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade aumentada ou desfecho, pois o estado do paciente permanece desconhecido. Diante da suspeita de relação com o medicamento, é fundamental acompanhamento médico para investigação da causa e monitoramento da evolução clínica.

O medicamento Dipirona, cujo princípio ativo é o metamizol de magnésio, foi relacionado a uma alergia documentada após administração, caracterizada como hipersensibilidade documentada a produto administrado e classificada como lesão ou complicação de procedimento. Não há sinais de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta adotada foi adequada, resultando em resolução do quadro, e recomenda-se evitar novas exposições ao medicamento e realizar avaliação com especialista para confirmação diagnóstica.

O medicamento Alprazolam, com princípio ativo alprazolam, foi associado a um quadro de dor relacionado à hipersensibilidade, enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade aumentada ou desfecho, pois o estado do paciente permanece desconhecido. Diante da suspeita de reação alérgica, é importante acompanhamento clínico para investigação da causa e orientação sobre o uso futuro do medicamento.

O medicamento Anastrozol, cujo princípio ativo é o anastrozole, foi associado a um quadro de dor relacionado à hipersensibilidade, que é uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave neste caso, e a evolução do quadro não foi informada. A suspeita de reação alérgica sugere a necessidade de avaliação clínica para confirmação e orientação sobre o uso futuro do medicamento, conforme recomendações para quadros leves de alergia medicamentosa.

O medicamento Kisqali, que contém o princípio ativo succinato de ribociclibe, apresentou relato de dor associada a hipersensibilidade, indicando uma possível reação alérgica do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade importante ou desfecho grave, e o desfecho permanece desconhecido. Diante da suspeita de alergia, recomenda-se avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição de conduta, seguindo orientações para quadros leves de hipersensibilidade medicamentosa.

No caso da vitamina D, cujo princípio ativo é o colecalciferol, foi relatada tentativa de suicídio em contexto de hipersensibilidade medicamentosa, mas não há detalhes clínicos que permitam associar diretamente a gravidade da reação alérgica. O registro não indica desfecho grave nem evolução conhecida, sendo importante esclarecer que a suspeita de alergia medicamentosa deve ser avaliada por um especialista para confirmação e orientação adequada, especialmente quando há sintomas atípicos ou eventos graves associados.

A vitamina E, com princípio ativo acetato de tocoferol, foi relacionada a uma tentativa de suicídio em contexto de hipersensibilidade medicamentosa, porém não há informações suficientes para determinar a gravidade da reação alérgica ou o desfecho do caso. Diante da suspeita de alergia, é fundamental buscar avaliação médica especializada para investigação e definição de conduta, principalmente quando há manifestações incomuns ou potencialmente graves.

O medicamento Amplictil, cujo princípio ativo é a clorpromazina, foi associado a tentativa de suicídio em contexto de hipersensibilidade medicamentosa, sem detalhes adicionais sobre a gravidade da reação alérgica ou o desfecho

clínico. A suspeita de alergia medicamentosa requer avaliação médica para confirmação e orientação, especialmente em situações que envolvem sintomas graves ou eventos psiquiátricos concomitantes.

O medicamento Zolpidem, cujo princípio ativo também é zolpidem, foi associado a uma reação descrita como tentativa de suicídio, sendo classificada tecnicamente como hipersensibilidade medicamentosa. Apesar do termo técnico sugerir uma reação alérgica, o evento relatado não apresenta sintomas típicos de alergia, como urticária ou anafilaxia, e não há informações suficientes para afirmar gravidade clínica relevante, já que não foi considerado grave e o desfecho é desconhecido. A relação com o medicamento é suspeita, mas não há detalhes sobre a conduta adotada ou evolução do caso.

O medicamento Ritalina LA, cujo princípio ativo é o cloridrato de metilfenidato, foi relacionado a uma tentativa de suicídio, categorizada tecnicamente como hipersensibilidade medicamentosa. No entanto, não há descrição de sintomas alérgicos clássicos, e o evento não foi considerado grave, com desfecho desconhecido. A suspeita de relação com o medicamento existe, mas faltam informações sobre a conduta tomada ou evolução clínica, impossibilitando uma avaliação mais detalhada da gravidade ou necessidade de intervenção.

A azitromicina, cujo princípio ativo é azithromycin, foi associada a uma tentativa de suicídio, classificada tecnicamente como hipersensibilidade medicamentosa. Não há sintomas típicos de alergia relatados, e o evento não foi considerado grave, com desfecho desconhecido. A relação com o medicamento é suspeita, mas não há informações sobre a conduta adotada ou evolução do quadro, limitando a análise da gravidade clínica.

O medicamento Creon, cujo princípio ativo é pancreatina, foi relacionado a uma tentativa de suicídio, sendo tecnicamente classificado como hipersensibilidade medicamentosa. Não há sintomas clássicos de alergia descritos, o evento não foi considerado grave e o desfecho permanece desconhecido. A suspeita de relação com o medicamento existe, mas não há detalhes sobre a conduta adotada ou evolução clínica, impossibilitando uma avaliação mais precisa da gravidade.

O medicamento Dramin, cujo princípio ativo é dimenidrinato, foi associado a uma tentativa de suicídio, classificada tecnicamente como hipersensibilidade medicamentosa. Não há sintomas típicos de alergia relatados, o evento não foi considerado grave e o desfecho é desconhecido. A relação com o medicamento é suspeita, mas não há informações sobre a conduta tomada ou evolução do caso, limitando a análise da gravidade clínica.

O medicamento Budesonida, cujo princípio ativo é a budesonida micronizada, foi associado a uma reação descrita como tentativa de suicídio, mas o registro classifica o evento como hipersensibilidade medicamentosa, relacionada a alergias a medicamentos e distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade clínica relevante, desfecho ou ação adotada, e o caso é considerado suspeito, sem evidências de gravidade ou evolução relatadas.

O Aerolin, que contém sulfato de salbutamol micronizado como princípio ativo, foi relacionado a uma reação descrita como tentativa de suicídio, porém o evento está categorizado como hipersensibilidade medicamentosa, envolvendo alergias a medicamentos e distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhes sobre gravidade, desfecho ou conduta, e o caso é apenas suspeito, sem indicação de gravidade clínica ou evolução.

A Vitamina C, cujo princípio ativo é o ácido ascórbico, foi associada a uma reação descrita como tentativa de suicídio, mas o evento está classificado como hipersensibilidade medicamentosa, relacionada a alergias a medicamentos e distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou conduta, sendo o caso considerado suspeito e sem evidências clínicas de gravidade ou evolução.

A Vitamina A Retinol, com princípio ativo retinol, foi relacionada a uma reação descrita como tentativa de suicídio, mas o evento está categorizado como hipersensibilidade medicamentosa, envolvendo alergias a medicamentos e distúrbios do sistema imunitário. Não há dados sobre gravidade, desfecho ou ação tomada, e o caso é considerado suspeito, sem evidências clínicas de gravidade ou evolução.

O medicamento Clenil, cujo princípio ativo é dipropionato de beclometasona, foi associado a uma reação descrita como tentativa de suicídio, mas o evento está classificado como hipersensibilidade medicamentosa, relacionada a alergias a medicamentos e distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou conduta, sendo o caso considerado suspeito e sem evidências clínicas de gravidade ou evolução.

O medicamento Pulmozyme, cujo princípio ativo é a dornasa alfa, foi associado a uma tentativa de suicídio em um contexto de hipersensibilidade medicamentosa, classificada como uma reação do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade clínica relevante ou desfecho conhecido neste caso, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita. É importante monitorar pacientes para possíveis reações adversas, mesmo que incomuns, e buscar avaliação médica diante de sintomas inesperados.

O contraste Optiray 350 ultraject, que contém ioversol como princípio ativo, foi relacionado a um episódio de alergia ao contraste, caracterizando uma reação imunológica. Não há detalhes sobre a gravidade, desfecho ou evolução clínica, mas a suspeita de relação com o medicamento exige atenção, sendo fundamental relatar qualquer sintoma alérgico após o uso de contrastes e procurar avaliação médica imediata em caso de sinais de reação alérgica.

A vancomicina, cujo princípio ativo é vancomycin, foi associada a uma acidose metabólica exacerbada em um paciente com hipersensibilidade documentada ao produto administrado, levando a um desfecho fatal. A gravidade é confirmada pelo resultado em óbito, evidenciando a importância do monitoramento rigoroso e da avaliação prévia de alergias antes da administração deste antibiótico, especialmente em pacientes com histórico de reações adversas.

O medicamento Sucrofer, que tem como princípio ativo o sacarato de óxido férrico, foi relacionado a uma alergia documentada ao medicamento administrado, caracterizando uma hipersensibilidade. Não há indicação de gravidade relevante e o desfecho foi de recuperação completa, sugerindo que a conduta adotada foi eficaz para resolução do quadro, mas reforçando a necessidade de atenção a sinais de alergia durante o uso de medicamentos injetáveis.

O omeprazole, cujo princípio ativo é omeprazol magnésico, foi associado a um caso de cirrose hepática em um contexto de hipersensibilidade, classificada como quadro clínico alérgico do sistema imunológico. Não há evidência de gravidade importante nem desfecho conhecido, mas a relação suspeita com o medicamento indica a necessidade de acompanhamento médico para avaliação de possíveis reações adversas hepáticas durante o uso prolongado.

O medicamento Losartan, cujo princípio ativo é a losartana potássica, foi associado a um quadro de cirrose hepática descrito como hipersensibilidade, o que sugere uma possível reação alérgica envolvendo o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e não foram relatados sinais de gravidade clínica ou evolução do caso, sendo a relação apenas suspeita.

O medicamento Amlodipine besilate, com princípio ativo besilato de anlodipino, foi relacionado a um caso de cirrose hepática classificado como hipersensibilidade, indicando uma possível reação alérgica do sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade significativa ou desfecho, e a relação com o medicamento permanece suspeita, sem detalhes adicionais sobre a evolução clínica.

O medicamento Dipiron, cujo princípio ativo é dipirona, foi associado a um episódio de cirrose hepática descrito como hipersensibilidade, sugerindo uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade importante ou desfecho relatado, e a relação com o medicamento é apenas suspeita, sem informações adicionais sobre a conduta ou evolução do caso.

O medicamento Nexavar, com princípio ativo tosilato de sorafenibe, foi relacionado a um caso de cirrose hepática classificado como hipersensibilidade, indicando uma possível reação alérgica do sistema imunológico. Não há dados sobre gravidade relevante ou desfecho, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sem

detalhes sobre a evolução clínica ou conduta adotada.

O medicamento Clavulin, composto por amoxicilina sódica e clavulanato de potássio, foi associado a um episódio de alergia medicamentosa descrito como hipersensibilidade medicamentosa, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico. O caso não foi considerado grave e evoluiu para recuperação completa, indicando resolução do quadro após a conduta adotada, embora detalhes específicos sobre o manejo não tenham sido informados.

O medicamento Sacarato de hidróxido férrico interlabo, cujo princípio ativo é o complexo de hidróxido férrico polimaltose, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como um distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave, e não foram relatados detalhes sobre a evolução clínica ou conduta adotada. A reação sugere um quadro alérgico leve, sendo importante considerar avaliação clínica para confirmação e orientação adequada, conforme as diretrizes da ASBAI.

O medicamento Ultravist, que contém o princípio ativo iopromide, foi relacionado a um episódio de alergia espontânea (atopia), classificado como distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente. Diante de reações alérgicas leves a contrastes, recomenda-se observação clínica e, se necessário, avaliação com especialista para futuras exposições, seguindo as orientações da ASBAI.

O medicamento Velija, cujo princípio ativo é o cloridrato de duloxetina, foi associado a uma reação descrita como metástases em ossos, mas classificada tecnicamente como hipersensibilidade medicamentosa, um distúrbio do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou conduta, e a descrição clínica não permite afirmar relação causal clara entre o evento e o medicamento; recomenda-se investigação clínica detalhada para esclarecimento.

O medicamento Zometa, com princípio ativo ácido zoledrônico monohidratado, foi relacionado a uma reação descrita como metástases em ossos, mas tecnicamente classificada como hipersensibilidade medicamentosa, pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. Não há dados sobre gravidade, desfecho ou conduta, e a descrição não permite afirmar relação causal direta; é fundamental avaliação clínica criteriosa para melhor definição do quadro.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é succinato de ribociclib, foi associado a uma reação descrita como metástases em ossos, mas classificada tecnicamente como hipersensibilidade medicamentosa, um distúrbio do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou conduta, e a relação causal entre o evento e o medicamento não está clara; recomenda-se investigação clínica para esclarecimento do caso.

O medicamento Pregabalin od, cujo princípio ativo é o pregabalina, foi associado a um quadro de metástases em ossos, registrado como hipersensibilidade medicamentosa. No entanto, não há informações suficientes para afirmar gravidade clínica relevante, pois o evento não foi classificado como grave e o desfecho permanece desconhecido. A relação com alergia é apenas suspeita, e não há detalhes sobre conduta adotada ou evolução do caso.

O medicamento Anastrozole, com princípio ativo anastrozol, também foi relacionado a metástases em ossos sob suspeita de hipersensibilidade medicamentosa. Não há indicação de gravidade significativa, já que o evento não foi considerado grave e o desfecho é desconhecido. A suspeita de reação alérgica existe, mas faltam informações sobre a conduta tomada ou o resultado clínico.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é iopromida, foi associado a um episódio de alergia a contraste intravenoso, caracterizando uma reação de hipersensibilidade ao contraste. Não há dados suficientes para determinar a gravidade, desfecho ou conduta adotada, apenas que a relação com o medicamento é suspeita.

O medicamento Neblock, com princípio ativo cloridrato de nebivolol, foi relacionado a um caso de edema laríngeo, que é um inchaço na região da laringe e pode comprometer a respiração. Apesar do potencial risco, o evento não

foi classificado como grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando resolução do quadro após a conduta adotada, embora esta não tenha sido detalhada.

O medicamento Efluelda, que contém como princípio ativo a vacina influenza inativada fragmentada 4v, esteve associado a um episódio de edema laríngeo, caracterizado por inchaço na laringe. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou, sugerindo que a reação foi controlada e resolvida, sem maiores complicações relatadas.

O medicamento Dipirona, cujo princípio ativo é dipirona monoidratada, foi associado a um episódio de hipersensibilidade documentada após sua administração, caracterizando uma reação alérgica ao medicamento. Não há informações detalhadas sobre a gravidade clínica, desfecho ou conduta adotada neste caso, mas a suspeita de alergia medicamentosa exige atenção, pois pode variar de manifestações leves a graves, sendo fundamental evitar nova exposição e buscar avaliação médica para confirmação e orientação.

O medicamento Tolrest, que contém cloridrato de sertralina como princípio ativo, foi relacionado ao surgimento de dermatite, um quadro de irritação ou inflamação da pele, sugerindo uma possível reação alérgica ao medicamento. Não há detalhes sobre a gravidade, evolução ou conduta adotada, mas reações cutâneas ao uso de medicamentos devem ser avaliadas por um profissional de saúde para confirmação diagnóstica e definição do melhor manejo.

O Tolrest, cujo princípio ativo é cloridrato de sertralina, foi associado a desconforto abdominal, o que pode indicar uma reação adversa de natureza alérgica ou intolerância ao medicamento. Não há informações sobre a gravidade, evolução ou medidas tomadas, mas sintomas gastrointestinais após uso de medicamentos devem ser monitorados e avaliados por um médico para orientação adequada.

O medicamento Sinudoron, composto por Atropa bella-donna, Berberis vulgaris, Hydrastis canadensis, Nitrato de prata e outros componentes homeopáticos, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como não grave, com desfecho de recuperação completa. Neste caso, a reação foi resolvida sem complicações, mas é importante relatar qualquer episódio de alergia a medicamentos ao médico para evitar novas exposições e garantir segurança no tratamento futuro.

A vitamina B12, cujo princípio ativo é a cianocobalamina, foi associada a um quadro de imunodeficiência relatado como hipersensibilidade, embora não haja detalhes claros sobre a relação causal. O evento foi considerado não grave e o desfecho permanece desconhecido, sendo fundamental acompanhamento médico para esclarecer a natureza da reação e orientar condutas futuras.

O medicamento Vitamina D, cujo princípio ativo é o colecalciferol, está relacionado a um quadro de hipersensibilidade (reação alérgica) classificado como imunodeficiência, mas não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido. A suspeita de reação alérgica ao colecalciferol é rara e, neste caso, não há evidências clínicas de gravidade significativa, sendo importante observar sintomas e buscar avaliação médica caso haja sinais de alergia persistente.

A atorvastatina, apresentada como atorvastatina cálcica, foi associada a um episódio de hipersensibilidade (reação alérgica) descrito como imunodeficiência, sem sinais de gravidade ou desfecho informado. Embora reações alérgicas a estatinas sejam incomuns, é fundamental monitorar sintomas e procurar orientação médica se houver manifestações alérgicas, especialmente em caso de uso contínuo.

A levotiroxina sódica, identificada como levotiroxina sódica, foi relacionada a um quadro de hipersensibilidade (reação alérgica) do tipo imunodeficiência, sem gravidade relatada nem desfecho conhecido. Reações alérgicas a este medicamento são raras, mas qualquer sintoma sugestivo deve ser avaliado por um profissional de saúde para confirmação e conduta adequada.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é o succinato de ribociclibe, foi associado a um episódio de hipersensibilidade (reação alérgica) classificado como imunodeficiência, sem gravidade ou desfecho informado. Embora não haja sinais de gravidade, é importante que o paciente seja acompanhado para monitorar possíveis sintomas alérgicos durante o tratamento.

O sulfato de magnésio, também chamado de sulfato de magnesio, foi relacionado a uma alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), mas não há detalhes sobre gravidade ou evolução do caso. Em situações de suspeita de alergia a medicamentos, recomenda-se interromper o uso e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição da conduta, especialmente se houver sintomas persistentes ou recorrentes.

O medicamento Metoclopramida (princípio ativo: Metoclopramide) foi associado a um episódio de alergia documentada após administração, caracterizando uma reação de hipersensibilidade ao produto. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou necessidade de hospitalização, mas a suspeita de alergia medicamentosa exige suspensão do uso e avaliação médica para confirmação e orientação futura.

O medicamento Imiglucerase (princípio ativo: Imiglucerase) foi relacionado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), que resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, indicando gravidade clínica relevante. O desfecho do caso é desconhecido, mas a reação exigiu intervenção médica e reforça a importância de monitoramento rigoroso e contra-indicação de reexposição ao fármaco.

O medicamento Cosentyx (princípio ativo: Secuquinumabe) foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), embora não haja relato de gravidade ou necessidade de hospitalização, e o desfecho permaneça desconhecido. A suspeita de reação alérgica deve ser avaliada pelo médico para confirmação diagnóstica e definição de conduta, especialmente se houver sintomas recorrentes.

O medicamento Tramadol (princípio ativo: Tramadol) foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), sem gravidade relatada e com resolução completa do quadro. O paciente recuperou-se após a suspensão do medicamento, sendo importante evitar reexposição e informar profissionais de saúde sobre a reação.

O medicamento Omeprazole (princípio ativo: Omeprazole) foi associado a um quadro de dependência de oxigenoterapia, classificado como alergia a alimentos, embora a relação entre o evento e o medicamento não esteja clara. Não houve gravidade relatada e o paciente se recuperou, mas é fundamental reavaliar a indicação do uso e investigar outras possíveis causas para o sintoma.

O medicamento Prednisone, cujo princípio ativo é também Prednisone, foi associado a um quadro de dependência de oxigenoterapia, relacionado a uma reação de alergia a alimentos, classificada dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, pois o paciente se recuperou totalmente, e não há menção de complicações graves ou necessidade de intervenção além do suporte com oxigênio. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, e a evolução foi favorável, com resolução completa do quadro.

O medicamento Atenolol, com princípio ativo Atenolol, esteve envolvido em um episódio de dependência de oxigenoterapia, vinculado a uma reação de alergia a alimentos, dentro do contexto de distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa, já que o paciente se recuperou sem complicações, e a necessidade de oxigênio foi temporária. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, e o desfecho foi resolutivo.

O medicamento Creon 25000, cujo princípio ativo é Pancreatina, foi relacionado a um episódio de dependência de oxigenoterapia, associado a uma reação de alergia a alimentos, enquadrada nos distúrbios do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade importante, pois o paciente se recuperou completamente, e a necessidade de oxigênio foi transitória. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, e o quadro evoluiu para



resolução.

O medicamento Meropenem, com princípio ativo Meropeném, esteve associado a um caso de dependência de oxigenoterapia, relacionado a uma reação de alergia a alimentos, dentro da categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, já que o paciente se recuperou totalmente e não houve complicações adicionais. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, e o desfecho foi favorável, com resolução do quadro.

O medicamento Prednisolone, cujo princípio ativo é Prednisolone, foi associado a um episódio de dependência de oxigenoterapia, vinculado a uma reação de alergia a alimentos, classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade importante, pois o paciente se recuperou completamente e não houve complicações graves. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, e o desfecho foi resolutivo.

O medicamento Bactrim, que contém os princípios ativos sulfametoxazol e trimetoprima, foi associado a um quadro de dependência de oxigenoterapia, relacionado a uma reação alérgica do tipo alimentar, conforme classificação clínica de distúrbio do sistema imunitário. Apesar da gravidade não ter sido explicitamente informada, o desfecho foi de recuperação completa, sugerindo que a reação foi controlada e não evoluiu para formas graves. A relação entre o uso do medicamento e o evento adverso foi considerada suspeita, e a conduta adotada permitiu a resolução do quadro.

O medicamento Pulmozyme, cujo princípio ativo é a dornase alfa, esteve relacionado a dependência de oxigenoterapia em um contexto de reação alérgica alimentar, classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, e o paciente se recuperou totalmente após o evento, indicando que a reação foi adequadamente manejada. O evento foi considerado suspeito em relação ao uso do medicamento.

O medicamento Omeprazole, com princípio ativo omeprazol, foi associado a dependência de oxigenoterapia em um quadro de hipersensibilidade medicamentosa, dentro da categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade importante, e o paciente encontra-se em recuperação, sugerindo que a reação está sendo resolvida de forma satisfatória. A relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Prednisona, cujo princípio ativo é a prednisona, foi relacionado a dependência de oxigenoterapia em um contexto de hipersensibilidade medicamentosa, classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade significativa, e o paciente está em processo de recuperação, indicando que a reação está sendo controlada. O evento adverso foi considerado suspeito em relação ao uso do medicamento.

O medicamento Atenolol, com princípio ativo atenolol, esteve associado a dependência de oxigenoterapia em um quadro de hipersensibilidade medicamentosa, enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade elevada, e o paciente está em recuperação, o que sugere que a reação está sendo resolvida adequadamente. A relação entre o uso do medicamento e o evento adverso foi considerada suspeita.

O medicamento Creon 25000, cujo princípio ativo é a pancreatina, foi associado a um quadro de dependência de oxigenoterapia, interpretado como uma possível reação de hipersensibilidade medicamentosa. Embora o evento tenha sido classificado como relacionado a distúrbios do sistema imunitário, não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente encontra-se em recuperação ou resolvendo o quadro. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico, observando a evolução dos sintomas e evitando reexposição ao medicamento suspeito.

O Meropenem, que tem como princípio ativo o meropeném, foi relacionado a dependência de oxigenoterapia, sugerindo uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. O evento está vinculado a distúrbios do sistema imunitário, mas não foi considerado grave, já que o paciente está em recuperação ou resolvendo o quadro. Recomenda-se monitoramento clínico e evitar o uso futuro do medicamento suspeito, conforme evolução apresentada.

O medicamento Prednisolone, com princípio ativo prednisolone, foi associado a dependência de oxigenoterapia, caracterizando uma possível hipersensibilidade medicamentosa. O quadro está relacionado a distúrbios do sistema imunitário, mas não foi considerado grave, pois o paciente está em recuperação ou resolvendo. A orientação é manter acompanhamento médico e evitar nova exposição ao prednisolone, conforme evolução clínica.

O Bactrim, que contém sulfametoxazol e trimetoprima como princípios ativos, foi relacionado a dependência de oxigenoterapia, indicando uma possível reação de hipersensibilidade medicamentosa. O evento está associado a distúrbios do sistema imunitário, mas não foi considerado grave, já que o paciente está em recuperação ou resolvendo. Recomenda-se acompanhamento clínico e evitar reexposição ao Bactrim, conforme evolução dos sintomas.

O medicamento Pulmozyme, cujo princípio ativo é a dornase alfa, foi associado a dependência de oxigenoterapia, interpretada como uma possível hipersensibilidade medicamentosa. O quadro está relacionado a distúrbios do sistema imunitário, mas não foi considerado grave, pois o paciente está em recuperação ou resolvendo. A conduta recomendada é manter acompanhamento médico e evitar nova exposição ao medicamento suspeito, conforme evolução clínica.

O medicamento Furosemida, cujo princípio ativo é furosemida sódica, foi associado a um quadro de trombose, interpretado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta do sistema imunológico ao medicamento. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, pois o paciente encontra-se em recuperação ou com resolução do quadro, e não há menção de complicações graves ou risco à vida. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, e a conduta adotada foi acompanhar a evolução clínica até a melhora.

A Bromoprida, cujo princípio ativo é bromoprida, foi relacionada ao desenvolvimento de trombose, caracterizada como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta adversa do sistema imunológico ao medicamento. Não há evidências de gravidade importante, já que o paciente está em recuperação ou com resolução do quadro, e não foram relatadas complicações graves. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, e a conduta foi monitorar a evolução clínica até a melhora.

O medicamento Pantoprazol, com princípio ativo pantoprazol sódico sesqui-hidratado, foi associado a um episódio de trombose, interpretado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta do sistema imunológico ao medicamento. Não há sinais de gravidade significativa, pois o paciente está em recuperação ou com resolução do quadro, sem relato de complicações graves. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, e a conduta foi acompanhar clinicamente até a melhora.

A Rivaroxabana, cujo princípio ativo é rivaroxabana, foi relacionada ao surgimento de trombose, considerada uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta adversa do sistema imunológico ao medicamento. Não há indícios de gravidade relevante, já que o paciente está em recuperação ou com resolução do quadro, e não foram relatadas complicações graves. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, e a conduta foi monitorar a evolução clínica até a melhora.

O medicamento Vectibix, cujo princípio ativo é panitumumabe, foi associado a um caso de trombose, interpretado como uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta do sistema imunológico ao medicamento. Não há evidências de gravidade importante, pois o paciente está em recuperação ou com resolução do quadro, sem relato de complicações graves. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, e a conduta foi acompanhar clinicamente até a melhora.

O medicamento Simeticona, cujo princípio ativo é simeticone, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (reação alérgica), classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso evoluiu para recuperação completa, e não foi considerado grave. A conduta foi adequada, com resolução do quadro, não sendo necessário tratamento adicional.

O medicamento Cloridrato de ondansetrona, com princípio ativo cloridrato de ondansetrona, esteve relacionado a um episódio de hipersensibilidade (reação alérgica), enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando que a reação foi leve e manejada de forma apropriada.

A Dipirona, cujo princípio ativo é dipirona, foi associada a uma reação de hipersensibilidade (alergia), classificada como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi grave e o paciente apresentou recuperação completa, sugerindo que a reação foi leve e controlada sem complicações.

O Carbonato de cálcio, com princípio ativo carbonato de cálcio, esteve envolvido em um caso de hipersensibilidade (reação alérgica), categorizado como distúrbio do sistema imunitário. Não houve gravidade significativa, pois o paciente se recuperou totalmente, indicando que a reação foi leve e não exigiu intervenções adicionais.

O medicamento Anastrozol, cujo princípio ativo é anastrozole, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou, mostrando que a reação foi leve e adequadamente resolvida.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é o succinato de ribociclibe, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (reação alérgica), classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento, e não há menção de complicações graves. A conduta recomendada em casos de hipersensibilidade leve é a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento clínico, com encaminhamento ao especialista se necessário.

A simeticona, também conhecida pelo princípio ativo simeticone, foi relacionada a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, que é uma reação alérgica do sistema imune. O caso não foi considerado grave, já que houve recuperação completa do paciente. Em situações como essa, a orientação é interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação do diagnóstico e definição do plano de controle, especialmente se houver recorrência.

O cloridrato de ondansetrona foi associado a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, caracterizada por resposta alérgica do sistema imunológico. O evento não foi grave, pois o paciente se recuperou sem complicações. Nessas situações, recomenda-se suspender o uso do medicamento e realizar acompanhamento médico para evitar novas exposições e avaliar a necessidade de investigação adicional.

A dipirona, cujo princípio ativo é a própria dipirona, esteve envolvida em um caso de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica desencadeada pelo medicamento. O episódio não foi grave, já que o paciente se recuperou totalmente. A conduta adequada é interromper o uso do medicamento e procurar orientação médica para confirmação do diagnóstico e prevenção de futuras reações.

O carbonato de cálcio foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, indicando uma reação alérgica do sistema imunológico. O caso não apresentou gravidade, pois houve resolução completa dos sintomas. A recomendação é suspender o uso do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Anastrozol (princípio ativo: Anastrozole) foi associado a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa, que é uma reação alérgica do sistema imunológico a medicamentos. Neste caso, não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento, e não houve menção de complicações graves. A conduta recomendada em situações semelhantes é a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento clínico, com encaminhamento ao especialista para investigação e confirmação diagnóstica, conforme orientações da ASBAI.

O medicamento Kisqali (princípio ativo: succinato de ribociclibe) foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, caracterizado por uma resposta alérgica do sistema imunológico ao fármaco. Não há sinais de gravidade importante, já que o paciente se recuperou completamente e não houve evolução para quadros críticos. Em casos como este, recomenda-se interromper o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação da alergia e definição do melhor manejo, seguindo as diretrizes clínicas.

A Cefazolina (princípio ativo: cefazolina sódica) foi associada a uma reação de alergia medicamentosa, que consiste em uma resposta do sistema imunológico ao antibiótico. O caso não apresentou gravidade significativa, pois o paciente se recuperou sem complicações. A orientação clínica é suspender o uso do medicamento e procurar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras, conforme as recomendações da ASBAI.

O contraste Omnipaque (princípio ativo: ioexol) foi relacionado a uma reação alérgica ao contraste, que é uma resposta do sistema imunológico ao agente utilizado em exames de imagem. O evento não foi grave, já que o paciente se recuperou totalmente. Nessas situações, recomenda-se evitar novas exposições ao mesmo contraste e informar a equipe médica sobre o episódio para planejamento de exames futuros com alternativas seguras, conforme as orientações clínicas.

O medicamento Xylocaina (princípio ativo: lidocaína) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica do sistema imunológico ao anestésico local. Não houve gravidade relevante, pois o paciente se recuperou completamente após o evento. A conduta recomendada é evitar o uso futuro do medicamento suspeito e buscar avaliação com especialista para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras, conforme as diretrizes clínicas.

O medicamento Omnipaque, cujo princípio ativo é o ioexol, foi associado a um episódio de alergia a contraste intravenoso, reação que se enquadra nos distúrbios do sistema imunitário e é classificada como alergia medicamentosa. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento, e não há menção de complicações ou necessidade de intervenção emergencial. A conduta recomendada, conforme diretrizes clínicas, é evitar novas exposições ao contraste e informar a equipe médica sobre o histórico de alergia, garantindo acompanhamento especializado se houver necessidade futura de exames com contraste.

O medicamento Glifage, que contém o princípio ativo metformina, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa, embora a reação relatada tenha sido metástases em ossos, o que não caracteriza uma reação alérgica típica. Não há evidências de gravidade significativa, já que o paciente se recuperou do evento e não houve desfecho grave. A recomendação é manter o acompanhamento clínico, esclarecer a natureza da reação e, se houver dúvida sobre alergia verdadeira, buscar avaliação com especialista para confirmação diagnóstica.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é o succinato de ribociclibe, foi associado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, embora a reação descrita como metástases em ossos não seja compatível com manifestações alérgicas clássicas. O caso não foi considerado grave, pois houve recuperação completa do paciente. Recomenda-se esclarecer o tipo de reação apresentada e, se persistirem dúvidas sobre alergia, realizar avaliação especializada para evitar restrições desnecessárias ao tratamento.

O medicamento Anastrozole, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, mas a reação descrita como metástases em ossos não corresponde a manifestações alérgicas típicas. O paciente se recuperou totalmente, sem gravidade associada. A conduta sugerida é revisar o histórico clínico para diferenciar eventos adversos do próprio medicamento de reações alérgicas, buscando avaliação com alergista se houver suspeita de alergia verdadeira.

O medicamento Fulvestrant, cujo princípio ativo é o fulvestranto, foi associado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, sendo a reação relatada metástases em ossos, o que não caracteriza uma reação alérgica clássica. O caso não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou completamente. Recomenda-se esclarecer a natureza da reação e, se houver dúvida sobre alergia, buscar avaliação especializada para evitar restrições desnecessárias ao tratamento.

O medicamento Azitromicina, cujo princípio ativo é Azithromycin, foi associado a um caso de hipogamaglobulinemia, que significa uma redução dos níveis de imunoglobulinas no sangue, podendo aumentar a suscetibilidade a infecções. Embora o registro relacione a reação ao medicamento e a classifique como suspeita, não há indicação de gravidade elevada nem informações sobre o desfecho do caso, sugerindo que a situação não foi considerada grave no contexto clínico informado.

O medicamento Mefex, com princípio ativo Axetil cefuroxima, está relacionado a um episódio de hipogamaglobulinemia, ou seja, uma diminuição das defesas do organismo devido à baixa de imunoglobulinas, o que pode facilitar infecções. A reação foi considerada suspeita, mas não há evidências de gravidade significativa nem detalhes sobre a evolução do quadro, indicando que não foi classificada como grave.

O medicamento Budesonida, cujo princípio ativo é Budesonida micronizada, foi associado a hipogamaglobulinemia, que é a redução dos anticorpos no sangue e pode aumentar o risco de infecções. O caso foi considerado suspeito, sem relato de gravidade importante ou desfecho conhecido, sugerindo que não houve complicações graves relatadas.

O medicamento Tecnomet, com princípio ativo Methotrexate, foi relacionado a um caso de hipogamaglobulinemia, que é a diminuição dos níveis de imunoglobulinas e pode comprometer a imunidade. A reação foi considerada suspeita, sem indicação de gravidade relevante e sem informações sobre o desfecho, o que sugere ausência de complicações graves no registro.

O medicamento Leflunomida, cujo princípio ativo é Leflunomide, foi associado a hipogamaglobulinemia, caracterizada pela redução dos anticorpos no sangue e possível aumento do risco de infecções. O evento foi considerado suspeito, não classificado como grave e sem desfecho informado, indicando que não houve gravidade clínica significativa relatada.

O medicamento Ácido fólico (princípio ativo: Ácido fólico) foi associado a um quadro de hipogamaglobulinemia, que significa uma redução dos anticorpos no sangue e pode indicar uma alteração do sistema imunológico, embora neste caso não haja evidências de gravidade clínica relevante ou desfecho conhecido. A reação foi classificada como suspeita, sem informações sobre evolução ou necessidade de intervenção específica.

A Venlafaxina (princípio ativo: Venlafaxine) foi relacionada a hipogamaglobulinemia, uma condição em que há diminuição dos anticorpos circulantes, sugerindo possível impacto no sistema imunológico, mas sem sinais de gravidade ou desfecho relatado. O evento foi considerado suspeito, sem detalhes sobre a evolução clínica ou conduta adotada.

O medicamento Puran T4 (princípio ativo: Levotiroxina sódica) apresentou suspeita de hipogamaglobulinemia, que é uma redução dos níveis de anticorpos e pode indicar alteração imunológica, porém não há indicação de gravidade ou desfecho conhecido neste caso. Não foram informadas ações tomadas ou evolução do quadro.

Hyqvia (princípio ativo: Imunoglobulina humana) foi associado a hipogamaglobulinemia, caracterizada por baixos níveis de anticorpos, o que pode afetar a defesa do organismo, mas neste registro não há sinais de gravidade ou desfecho informado. O evento é suspeito e não há detalhes sobre a conduta ou evolução clínica.

O medicamento Meropenem (princípio ativo: Meropenem sodium carbonate) foi relacionado a um quadro de alergia espontânea (atopia), que envolve uma resposta alérgica do sistema imunológico, mas sem sinais de gravidade

clínica relevante e com evolução descrita como em recuperação ou resolvendo. O evento foi considerado suspeito e não há informações adicionais sobre intervenções necessárias.

O medicamento Dipirona, cujo princípio ativo também é dipirona, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa, tecnicamente chamada de hipersensibilidade medicamentosa. Essa reação faz parte dos distúrbios do sistema imunitário e se enquadra na categoria de alergias a medicamentos. Não há indicação de gravidade aumentada ou complicações, e o desfecho foi de recuperação completa, sugerindo que a reação foi leve e resolvida após a suspensão do medicamento suspeito.

A Amicacina, antibiótico cujo princípio ativo é a amicacina, desencadeou uma reação de alergia a antibiótico, caracterizada como hipersensibilidade medicamentosa. Esse tipo de reação envolve o sistema imunológico e está classificada entre as alergias a medicamentos. Não há sinais de gravidade ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente, indicando que a reação foi leve e controlada com a interrupção do uso do antibiótico.

O medicamento Sacarato de hidróxido férrico Interlabo, cujo princípio ativo é o complexo de hidróxido férrico polimaltose, foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa, tecnicamente chamada de hipersensibilidade medicamentosa. Essa reação faz parte dos distúrbios do sistema imunitário e está dentro da categoria de alergias a medicamentos. Não houve gravidade relatada e o paciente se recuperou, sugerindo que a reação foi leve e resolvida após a suspensão do medicamento.

A Cefazolina, antibiótico cujo princípio ativo é a cefazolina sódica, foi associada a uma reação de alergia a antibiótico, tecnicamente denominada hipersensibilidade medicamentosa. Essa reação envolve o sistema imunológico e está classificada entre as alergias a medicamentos. Não há evidências de gravidade ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente, indicando que a reação foi leve e controlada com a interrupção do uso do antibiótico.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, foi relacionado a um episódio de vermelhidão na pele, caracterizado como hipersensibilidade documentada ao produto administrado. Essa reação está incluída entre as complicações de procedimentos e problemas relacionados ao uso do produto, mas não há indicação de gravidade aumentada ou complicações. O paciente se recuperou completamente, sugerindo que a reação foi leve e resolvida após a suspensão do agente de contraste.

O medicamento Irinotecan (princípio ativo: Irinotecano) foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. O evento foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando a necessidade de monitoramento e intervenção médica imediata. Após a conduta adequada, o paciente evoluiu para recuperação completa.

O medicamento Fluorouracil (princípio ativo: Fluoruracila) desencadeou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, relacionada a distúrbios do sistema imunitário. A gravidade do caso foi confirmada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, indicando um quadro clínico que exigiu atenção médica intensiva. O paciente apresentou resolução total do quadro após as medidas adotadas.

O medicamento Folinic acid (princípio ativo: Ácido folínico) esteve envolvido em uma reação alérgica classificada como hipersensibilidade, dentro do contexto de distúrbios do sistema imunitário. O evento foi considerado grave devido à hospitalização ou prolongamento da internação, o que reforça a importância de acompanhamento médico rigoroso. O desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente.

O medicamento Erbitux (princípio ativo: Cetuximabe) provocou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, enquadrada nos distúrbios do sistema imunitário. O caso foi considerado grave, pois houve necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, demonstrando a relevância de intervenção médica imediata. O paciente se recuperou totalmente após o manejo clínico.

O medicamento Escopolamina (princípio ativo: Bromidrato de hiosciamina) foi relacionado a um episódio de alergia do tipo hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há informação sobre gravidade ou necessidade de hospitalização, mas o paciente evoluiu para recuperação completa após a reação.

O medicamento Cefazolina (princípio ativo: Cefazolin) foi associado a um quadro de alergia medicamentosa, também chamada de hipersensibilidade medicamentosa, que se enquadra nos distúrbios do sistema imunitário. A reação foi considerada não grave, pois não há indicação de gravidade aumentada ou complicações clínicas relevantes, e o desfecho foi de recuperação completa do paciente. Em situações como essa, é importante reconhecer sinais de alergia e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições ao medicamento.

O medicamento Pregabalina (princípio ativo: Pregabalin) foi relacionado a um episódio de ânsia de vômito, interpretado como manifestação de hipersensibilidade (alergia), dentro do contexto de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade aumentada ou complicações, e o desfecho do caso é desconhecido. Diante de sintomas leves como esse, recomenda-se observar a evolução e procurar orientação médica caso haja piora ou persistência dos sintomas.

O medicamento Omeprazole (princípio ativo: Omeprazole) foi associado a ânsia de vômito, considerada uma possível manifestação de hipersensibilidade (alergia), enquadrada em quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade ou complicações relevantes, e o desfecho permanece desconhecido. Em casos leves como este, é indicado monitorar os sintomas e buscar avaliação médica se houver agravamento ou persistência.

O medicamento Cosentyx (princípio ativo: Secuquinumabe) foi relacionado a ânsia de vômito, interpretada como possível reação de hipersensibilidade (alergia), dentro do espectro de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há indícios de gravidade aumentada ou complicações, e o desfecho não foi informado. Para sintomas leves, recomenda-se acompanhamento dos sintomas e avaliação médica caso haja piora.

O medicamento Zolpidem (princípio ativo: Zolpidem) foi associado a ânsia de vômito, considerada uma manifestação de hipersensibilidade (alergia), classificada entre quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade ou complicações, e o desfecho é desconhecido. Em situações leves como essa, é importante monitorar os sintomas e procurar orientação médica se houver agravamento.

O medicamento Butilbrometo de escopolamina + dipirona sódica, contendo os princípios ativos butilbrometo de escopolamina e dipirona, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário. A reação foi considerada não grave, pois não há indicação de gravidade clínica relevante no registro, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. Em situações como essa, recomenda-se evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Clavulin BD, que contém amoxicilina trihidrato e clavulanato de potássio, foi relacionado a um episódio de breve perda de consciência, interpretado como manifestação de hipersensibilidade (alergia) segundo a classificação clínica. Não há evidência de gravidade significativa, pois o evento não foi considerado grave, e o desfecho permanece desconhecido. Diante de reações alérgicas a antibióticos, é importante suspender o uso e procurar avaliação médica para investigação e definição de alternativas terapêuticas.

O medicamento Colecalciferol, cujo princípio ativo é o colecalciferol, foi associado ao aparecimento de sangue nas fezes, sendo a reação classificada como alergia ao leite, um distúrbio do sistema imunitário. Não há informações sobre gravidade, mas o desfecho indica que o quadro permanece em andamento, sem resolução até o momento. Nesses casos, é fundamental buscar avaliação médica para investigação da causa, confirmação diagnóstica e definição de conduta adequada, especialmente se houver suspeita de alergia alimentar associada ao uso do medicamento.

O medicamento Dexfer, que contém complexo de hidróxido férrico polimaltose, foi relacionado ao sintoma de sangue nas fezes, sendo a reação classificada como alergia ao leite, um distúrbio do sistema imunitário. Não há dados sobre gravidade, e o quadro segue sem resolução, conforme o desfecho informado. Diante desse tipo de manifestação, recomenda-se avaliação médica para investigação da relação causal, confirmação diagnóstica e orientação sobre a continuidade ou substituição do tratamento.

O medicamento Bactrim, composto por sulfametoxazol e trimetoprima, foi associado ao aumento da frequência urinária, interpretado como hipersensibilidade medicamentosa, um tipo de alergia relacionada ao sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o desfecho permanece desconhecido. Em situações de suspeita de alergia medicamentosa, é importante interromper o uso do medicamento e procurar orientação médica para avaliação e escolha de alternativas seguras.

O medicamento Sertraline, cujo princípio ativo também é sertralina, foi associado ao aumento da frequência urinária, um possível sinal de hipersensibilidade medicamentosa. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave neste caso, e a reação foi considerada não grave, com desfecho desconhecido. A relação entre o uso do medicamento e o evento adverso é suspeita, e recomenda-se observar a evolução dos sintomas e buscar avaliação médica caso haja piora ou persistência.

O Nausebron, que contém cloridrato de ondansetrona como princípio ativo, apresentou relato de aumento da frequência urinária, sugerindo uma possível hipersensibilidade ao medicamento. Não há evidências de gravidade significativa ou complicações graves, e o desfecho permanece desconhecido. A relação entre o uso do medicamento e o evento é considerada suspeita, sendo importante monitorar os sintomas e procurar orientação médica se necessário.

O medicamento Diphenhydramine, cujo princípio ativo é a difenidramina, foi relacionado ao aumento da frequência urinária, caracterizando uma possível reação de hipersensibilidade. Não há sinais de gravidade ou evolução grave, e o desfecho do caso não foi informado. A suspeita de relação com o medicamento existe, e recomenda-se acompanhamento dos sintomas e avaliação médica caso haja agravamento.

O Methylprednisolone, com princípio ativo de mesmo nome, foi associado ao aumento da frequência urinária, indicando uma possível hipersensibilidade ao medicamento. Não há evidências de gravidade ou complicações graves, e o desfecho é desconhecido. A relação com o medicamento é suspeita, sendo importante observar a evolução clínica e buscar orientação médica se necessário.

O medicamento Hydrocortisone, cujo princípio ativo também é hidrocortisona, apresentou relato de aumento da frequência urinária, sugerindo uma possível reação de hipersensibilidade. Não há sinais de gravidade ou evolução grave, e o desfecho permanece desconhecido. A relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo recomendada a observação dos sintomas e avaliação médica caso haja persistência ou piora.

O medicamento Lemtrada, cujo princípio ativo é o alentuzumabe, foi associado ao aumento da frequência urinária em um caso de hipersensibilidade medicamentosa, classificada como uma reação alérgica a medicamentos. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave, e o desfecho clínico permanece desconhecido. A conduta recomendada, baseada nas diretrizes clínicas, é observar atentamente o paciente, evitar reexposição ao medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições.

O medicamento Ultravist, que contém iopromide como princípio ativo, foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do sistema imunológico a substâncias químicas. O caso não foi classificado como grave e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta adequada inclui evitar novas exposições ao contraste e informar a equipe médica sobre o histórico de alergia para prevenir recorrências.



O medicamento Clariscan, cujo princípio ativo é o gadobenato de dimeglumina, foi associado a uma reação alérgica ao contraste, considerada uma manifestação de hipersensibilidade do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade significativa e o paciente se recuperou após o evento. Recomenda-se evitar o uso futuro deste contraste e comunicar o histórico de alergia ao serviço de saúde para garantir segurança em exames posteriores.

O medicamento Escitalopram, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um caso de leucopenia (redução dos glóbulos brancos), interpretada como uma manifestação de hipersensibilidade. Não há indicação de gravidade ou complicações graves, e o paciente se recuperou após o evento. A orientação é suspender o uso do medicamento suspeito e realizar acompanhamento médico para monitorar possíveis recorrências ou necessidade de ajuste terapêutico.

O medicamento Calcium citrate malate, cujo princípio ativo é o citrato de cálcio, foi associado a um episódio de leucopenia, considerado uma reação de hipersensibilidade. Não há sinais de gravidade ou evolução desfavorável, e o paciente se recuperou após o evento. Recomenda-se evitar o uso futuro do produto e buscar avaliação médica para esclarecimento da causa e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Simvastatin, cujo princípio ativo é a Sinvastatina, foi associado a um quadro de leucopenia, que significa redução dos glóbulos brancos, em um contexto de hipersensibilidade (reação alérgica). A reação foi classificada como não grave, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento. Não há informações adicionais sobre a conduta adotada, mas o desfecho favorável indica resolução espontânea ou após intervenção médica adequada.

O medicamento Levothyroxine, com princípio ativo de mesmo nome, esteve relacionado a um episódio de leucopenia, ou seja, diminuição dos glóbulos brancos, em um contexto de hipersensibilidade (reação alérgica). A reação não foi considerada grave, já que o paciente se recuperou completamente. O registro não detalha a conduta adotada, mas o desfecho indica resolução do quadro.

O medicamento Ossone, que contém os princípios ativos calcium aminoacetate, citrato de cálcio, colecalciferol e menaquinone-7, foi associado a leucopenia, caracterizada pela redução dos glóbulos brancos, em um contexto de hipersensibilidade (reação alérgica). A reação não foi considerada grave, pois o paciente se recuperou totalmente. Não há detalhes sobre a conduta, mas o desfecho sugere resolução do evento adverso.

O medicamento Vit d, cujo princípio ativo é o ergocalciferol, esteve relacionado a um caso de leucopenia, que é a diminuição dos glóbulos brancos, em um contexto de hipersensibilidade (reação alérgica). A reação não foi considerada grave, já que o paciente se recuperou completamente. Não há informações sobre a conduta adotada, mas o desfecho indica resolução do quadro.

O medicamento Xgeva, com princípio ativo denosumabe, foi associado a leucopenia, ou seja, redução dos glóbulos brancos, em um contexto de hipersensibilidade (reação alérgica). A reação não foi considerada grave, pois o paciente se recuperou totalmente. Não há detalhes sobre a conduta, mas o desfecho sugere resolução do evento adverso.

O medicamento Letrozol, cujo princípio ativo é letrozole, foi associado a um quadro de leucopenia, que significa redução dos glóbulos brancos, em um contexto de hipersensibilidade (reação alérgica). Apesar de não haver indicação de gravidade elevada ou complicações, o paciente se recuperou totalmente após o evento. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita, e não houve necessidade de medidas emergenciais, sendo o desfecho favorável.

O Kisqali, que tem como princípio ativo o succinato de ribociclibe, esteve relacionado a um episódio de leucopenia, caracterizado por diminuição dos glóbulos brancos, em um contexto de hipersensibilidade (reação alérgica). Não há evidência de gravidade importante ou complicações associadas, e o paciente se recuperou completamente. A

relação entre o medicamento e a reação foi considerada suspeita, sem necessidade de intervenções adicionais.

O Optiray, cujo princípio ativo é ioversol, foi relacionado a uma reação alérgica ao contraste intravenoso, considerada clinicamente significativa devido à gravidade informada. O paciente apresentou sintomas compatíveis com alergia a contraste, que exigem atenção médica imediata, mas evoluiu para recuperação completa após o evento. A relação entre o uso do contraste e a reação foi considerada suspeita, e a conduta adequada inclui monitoramento e suporte durante o episódio.

O medicamento Ultravist, com princípio ativo iopromide, esteve associado a uma reação alérgica ao contraste, manifestando sintomas típicos de hipersensibilidade. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A relação entre o uso do contraste e a reação foi considerada suspeita, sem necessidade de intervenções emergenciais.

O Ancoron, cujo princípio ativo é o cloridrato de amiodarona, foi associado a uma frequência cardíaca anormal em um contexto de hipersensibilidade, sendo considerado um efeito clinicamente significativo e grave. O desfecho do caso é desconhecido, mas a gravidade do evento exige avaliação médica imediata e monitoramento rigoroso, já que alterações cardíacas podem representar risco à saúde. A relação entre o medicamento e a reação foi considerada suspeita.

O medicamento Xarelto, cujo princípio ativo é a rivaroxabana, foi associado a uma reação de frequência cardíaca anormal em um contexto de hipersensibilidade, classificada como um quadro clínico alérgico relacionado a distúrbios do sistema imunitário. A gravidade foi considerada clinicamente significativa, pois o evento foi marcado como grave, o que indica a necessidade de atenção médica imediata e acompanhamento rigoroso para avaliar possíveis riscos à saúde do paciente. O desfecho da reação é desconhecido e não há informações sobre a conduta adotada até o momento.

O medicamento Ozurdex, que contém dexametasona como princípio ativo, foi relacionado a uma lesão no braço em um contexto de hipersensibilidade, caracterizando um quadro alérgico do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, sugerindo que a reação não apresentou risco imediato à saúde do paciente. O desfecho permanece desconhecido e não há detalhes sobre a conduta adotada.

O medicamento Rosuvastatina cálcica, com o mesmo princípio ativo, foi associado a uma lesão no braço em um contexto de hipersensibilidade, enquadrando-se como um quadro alérgico do sistema imunitário. O evento não foi classificado como grave, indicando que não houve risco significativo à saúde do paciente. O desfecho é desconhecido e não há informações sobre a conduta tomada.

O medicamento Dprev, cujo princípio ativo é o colecalciferol, foi relacionado a uma lesão no braço em um contexto de hipersensibilidade, caracterizando um quadro alérgico do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, o que sugere ausência de risco imediato ao paciente. O desfecho da reação é desconhecido e não há informações sobre a conduta adotada.

O medicamento Trezete, que contém ezetimibe e rosuvastatina cálcica como princípios ativos, foi associado a uma lesão no braço em um contexto de hipersensibilidade, sendo classificado como um quadro alérgico do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, indicando que não houve risco relevante à saúde do paciente. O desfecho permanece desconhecido e não há detalhes sobre a conduta adotada.

O medicamento Forxiga, cujo princípio ativo é a dapagliflozina propanodiol monohidratada, foi associado a uma reação de hipersensibilidade manifestada como lesão no braço, sugerindo um quadro alérgico leve relacionado ao sistema imunológico. Não há indicação de gravidade importante ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Recomenda-se observar o quadro, evitar exposição ao medicamento até avaliação médica e buscar orientação especializada caso haja recorrência ou agravamento dos sintomas.

O Exodus, que contém oxalato de escitalopram como princípio ativo, foi relacionado a uma reação de hipersensibilidade caracterizada por lesão no braço, indicando um possível quadro alérgico leve do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade relevante nem informações sobre o desfecho, e a relação com o medicamento é suspeita. Recomenda-se monitorar os sintomas, evitar nova exposição ao medicamento e procurar avaliação médica para confirmação e orientação adequada.

O medicamento Livial, cujo princípio ativo é a tibolona, foi associado a uma reação de hipersensibilidade com lesão no braço, sugerindo um quadro alérgico leve relacionado ao sistema imunológico. Não há evidências de gravidade significativa nem informações sobre o desfecho, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Recomenda-se evitar o uso do medicamento até avaliação médica e buscar orientação especializada caso os sintomas persistam ou se agravem.

O Humira, que tem como princípio ativo o adalimumabe, foi relacionado a uma reação de hipersensibilidade manifestada por lesão no braço, indicando um quadro alérgico leve do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade importante nem desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é suspeita. Recomenda-se suspender o uso do medicamento até avaliação médica e procurar orientação especializada para confirmação diagnóstica e conduta adequada.

O medicamento Mavenclad, cujo princípio ativo é a cladribina, foi associado a uma reação classificada como alergia a alimentos, mas tecnicamente descrita como alergia a picada de artrópode, enquadrando-se em quadros clínicos alérgicos do sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente significativo, com gravidade reconhecida, porém o paciente evoluiu para recuperação completa. A relação com o medicamento é suspeita, e a conduta adequada inclui acompanhamento médico para evitar novas exposições e monitorar possíveis recorrências.

O medicamento Mavenclad (princípio ativo: Cladribine) foi associado a um quadro de alergia a alimentos, classificado como um distúrbio do sistema imunitário. A reação foi considerada clinicamente significativa, pois foi marcada como grave, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A descrição sugere que a manifestação alérgica foi relevante, exigindo atenção clínica, mas não há detalhes sobre a conduta adotada além do desfecho favorável.

O medicamento Metadona (princípio ativo: Methadone) esteve relacionado a um episódio de alergia, tecnicamente descrito como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente, indicando que a reação foi leve e não houve complicações importantes, sem necessidade de intervenções específicas relatadas.

O medicamento Duloxetina (princípio ativo: Duloxetine) foi associado a inchaço da face, caracterizado como uma reação de hipersensibilidade, dentro dos quadros clínicos alérgicos do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, mas o paciente ainda não se recuperou, sugerindo que a reação persiste e requer acompanhamento médico para monitoramento e possível ajuste do tratamento.

O medicamento Ajovy (princípio ativo: Fremanezumabe) esteve relacionado a inchaço da face, identificado como uma reação de hipersensibilidade do sistema imunitário. A reação não foi classificada como grave, porém o paciente permanece sem resolução do quadro, o que indica a necessidade de acompanhamento clínico até a completa recuperação.

O medicamento Erelzi (princípio ativo: Etanercepte) foi associado a um episódio de alergia, tecnicamente descrito como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há informações suficientes sobre gravidade, evolução ou conduta adotada, portanto não é possível detalhar a relevância clínica ou o desfecho deste caso.

O medicamento Patanol S, cujo princípio ativo é o cloridrato de olopatadina, foi associado a um relato de transtorno autístico em um contexto de alergia ocular. Embora a reação tenha sido classificada como suspeita e não grave, não há informações detalhadas sobre a gravidade clínica, desfecho ou conduta adotada. O caso sugere uma manifestação ocular possivelmente relacionada ao uso do medicamento, mas não há evidências suficientes para estabelecer uma relação causal direta ou orientar conduta específica.

O medicamento Trileptal, que contém oxcarbazepina como princípio ativo, foi relacionado a um caso de transtorno autístico em associação com sintomas de alergia ocular. A reação foi considerada suspeita, não grave e sem informações sobre desfecho ou conduta. Não há detalhes clínicos que permitam afirmar gravidade ou orientar manejo, sendo a relação apenas sugerida pelo relato.

O medicamento Dysport, cujo princípio ativo é a toxina botulínica tipo A, foi associado a um caso de toxicidade neuromuscular em um contexto de hipersensibilidade. A reação foi considerada suspeita, não grave e sem informações sobre desfecho ou conduta adotada. O relato sugere uma possível reação alérgica sistêmica, mas não há dados suficientes para detalhar a gravidade clínica ou orientar conduta específica.

O medicamento Clindamicina, com princípio ativo clindamicina, foi relacionado a um caso de alergia a antibiótico, caracterizado como hipersensibilidade medicamentosa. A reação foi considerada suspeita, mas não há informações sobre gravidade, desfecho ou conduta adotada. O relato sugere uma possível reação alérgica, mas faltam detalhes clínicos para classificar a gravidade ou orientar o manejo.

O medicamento Lidocaína, contendo epinefrina e cloridrato de lidocaína como princípios ativos, foi associado a um caso de alergia (hipersensibilidade), considerado suspeito e não grave. O desfecho informado foi de recuperação ou resolução do quadro, sugerindo que a reação foi autolimitada e não houve complicações clínicas relevantes.

O medicamento Cetamina, cujo princípio ativo é o cloridrato de cetamina, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade (termo técnico: hipersensibilidade), pertencente ao grupo de reações alérgicas clínicas. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente. A reação foi classificada como suspeita de estar relacionada ao uso do medicamento, e não há menção de complicações ou necessidade de intervenções adicionais, sugerindo um desfecho favorável após a suspensão ou manejo da exposição.

O Midazolam, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um episódio de alergia manifestado como hipersensibilidade, termo que indica uma reação alérgica do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave, já que o paciente se recuperou completamente e não houve agravamento clínico. A suspeita de relação com o medicamento foi registrada, e a evolução positiva sugere que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro, sem necessidade de medidas emergenciais.

O Propofol, cujo princípio ativo também é propofol, esteve envolvido em uma reação alérgica descrita como hipersensibilidade, termo utilizado para reações do sistema imunológico a medicamentos. O caso não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou sem complicações e a relação com o medicamento foi considerada suspeita. Não há relato de agravamento ou necessidade de intervenções adicionais, indicando que a conduta adotada foi eficaz para resolução do evento.

O Prohance, que tem como princípio ativo o gadoterídiol, foi associado a uma reação de alergia a contraste, caracterizada como uma resposta do sistema imunológico a substâncias químicas utilizadas em exames. O evento não foi considerado grave, já que o paciente se recuperou totalmente e não houve complicações. A relação com o medicamento foi considerada suspeita, e a evolução favorável sugere que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro, sem necessidade de intervenções emergenciais.

O Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, esteve relacionado a um episódio de alergia a contraste, que corresponde a uma reação do sistema imunológico a substâncias químicas usadas em exames de imagem. O caso

não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou completamente e não houve agravamento clínico. A suspeita de relação com o medicamento foi registrada, e a evolução positiva indica que a conduta adotada foi adequada para resolução do evento, sem necessidade de medidas adicionais.

O medicamento Iopromida (princípio ativo: Iopromide) foi associado a um quadro de alergia a contraste, reação que pode ocorrer após a administração de substâncias usadas em exames de imagem. Embora a gravidade não tenha sido especificada neste caso, o paciente se recuperou totalmente após o evento, indicando resolução do quadro. A conduta recomendada em situações de alergia a contraste inclui a suspensão da exposição ao agente suspeito, monitoramento dos sintomas e avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições.

O medicamento Ultravist (princípio ativo: Iopromide) desencadeou uma alergia a contraste intravenoso, reação considerada clinicamente significativa e classificada como grave devido ao potencial risco de complicações sistêmicas. O paciente se recuperou após o evento, o que sugere que as medidas adotadas foram eficazes. Em casos de alergia a contraste, é fundamental interromper a administração do agente, monitorar sinais vitais e buscar avaliação médica imediata para manejo adequado e prevenção de recorrências.

O medicamento Plasil (princípio ativo: Cloridrato de metoclopramida) foi relacionado a um episódio de sangramento, interpretado como manifestação de hipersensibilidade (reação alérgica). Não há indicação de gravidade aumentada ou desfecho definido neste caso, mas a ausência de gravidade sugere que o quadro não evoluiu para complicações maiores. Recomenda-se suspender o uso do medicamento e procurar avaliação médica para investigação da causa do sangramento e orientação sobre alternativas terapêuticas.

O medicamento Tassigna (princípio ativo: Cloridrato de nilotinibe monoidratado) foi associado a um episódio de sangramento, considerado uma manifestação de hipersensibilidade (reação alérgica). Não há evidência de gravidade aumentada nem desfecho conhecido, o que indica que o quadro pode ter sido autolimitado ou não evoluiu para complicações graves. A conduta recomendada é interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica para esclarecimento do quadro e definição do tratamento mais seguro.

O medicamento Fingolimod (princípio ativo: Fingolimode) foi relacionado a um episódio de anafilaxia, que é uma reação alérgica grave e potencialmente fatal caracterizada por sintomas sistêmicos. Apesar de não haver confirmação de gravidade aumentada ou desfecho informado, a anafilaxia exige suspensão imediata do medicamento e atendimento médico de urgência para administração de tratamento adequado, como adrenalina e suporte clínico, visando evitar complicações maiores.

O medicamento Fingolimod (princípio ativo Fingolimode) foi associado a um quadro de anafilaxia, uma reação alérgica grave caracterizada por hipersensibilidade imediata, que pode comprometer a vida do paciente. A gravidade é confirmada pela classificação como efeito clinicamente significativo e pelo registro de gravidade como 'Sim', indicando necessidade de atenção médica urgente. O desfecho da reação é desconhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sendo fundamental a suspensão do uso e acompanhamento especializado imediato.

A Carboplatina (princípio ativo Carboplatina) provocou uma reação alérgica, descrita como hipersensibilidade, que se manifestou de forma não grave, já que não há indicação de gravidade relevante e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A relação com o medicamento é suspeita, e a conduta adequada inclui a suspensão do agente e avaliação por especialista para evitar novas exposições.

O medicamento Dipiron (princípio ativo Dipirona) causou eritema cutâneo, uma reação de hipersensibilidade documentada ao produto administrado, caracterizada por vermelhidão na pele. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente após a reação, sendo importante evitar o uso futuro do medicamento e informar o profissional de saúde sobre o episódio.

A Bromoprida (princípio ativo Bromopride) foi relacionada a um quadro de alergia, descrito como hipersensibilidade, mas não há informações suficientes sobre a gravidade, evolução ou desfecho do caso. A relação com o medicamento é suspeita, e recomenda-se avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre o uso futuro.

O medicamento Soliris (princípio ativo Eculizumabe) foi associado a rigidez nos joelhos, interpretada como uma manifestação de hipersensibilidade medicamentosa. O evento não foi considerado grave e o desfecho permanece desconhecido, sendo importante monitorar o paciente e discutir com o médico a continuidade do tratamento.

O medicamento Pramipexole dihydrochloride, cujo princípio ativo é o dicloridrato de pramipexol, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso está em recuperação e não foi considerado grave, sugerindo uma reação leve, compatível com quadros clínicos alérgicos não complicados. A conduta recomendada é observar a evolução dos sintomas e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições ao medicamento.

O medicamento Minergi, que tem como princípio ativo o dicloridrato de pramipexol, apresentou relato de alergia manifestada como hipersensibilidade, enquadrada entre os distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e está em processo de recuperação, indicando uma reação leve, sem sinais de complicação. Recomenda-se acompanhamento clínico para monitorar a resolução dos sintomas e evitar reexposição ao medicamento até avaliação especializada.

O medicamento Quera, cujo princípio ativo é o dicloridrato de pramipexol, foi relacionado a um episódio de alergia descrito como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade, já que o quadro está em recuperação e não foi classificado como grave, sugerindo uma reação leve. A orientação é manter acompanhamento clínico e evitar o uso do medicamento até avaliação médica detalhada.

O medicamento Alprazolam, com princípio ativo de mesmo nome, foi associado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, classificada entre os distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e está em recuperação, o que indica uma manifestação leve e sem complicações. Recomenda-se observação dos sintomas e consulta médica para esclarecimento diagnóstico e orientação sobre o uso futuro do medicamento.

O medicamento Glifage, cujo princípio ativo é a metformina, foi relacionado a um quadro de alergia descrito como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade, pois o caso está em recuperação e não foi considerado grave, caracterizando uma reação leve. A conduta sugerida é manter acompanhamento clínico e evitar reexposição ao medicamento até avaliação médica adequada.

O medicamento Xgeva, cujo princípio ativo é o denosumabe, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações graves neste caso, e o paciente encontra-se em recuperação ou com resolução dos sintomas. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico para monitorar a evolução e evitar nova exposição ao medicamento, conforme orientação médica.

O Fulvestranto, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, também classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade importante relatados, e o paciente está em processo de recuperação ou resolução do quadro. Recomenda-se acompanhamento médico para garantir a completa resolução dos sintomas e evitar reexposição ao fármaco.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é o succinato de ribociclib, apresentou associação com uma reação de hipersensibilidade, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa, e o paciente está em recuperação ou com sintomas resolvendo. A orientação é manter o acompanhamento clínico e evitar nova exposição ao medicamento, conforme avaliação médica.

O Clariscan, que contém gadobenato de dimeglumina, foi relacionado a uma reação alérgica a contraste, classificada como clinicamente significativa e considerada grave, pois envolve distúrbios do sistema imunitário e pode apresentar risco aumentado em função da natureza do contraste. O paciente está em recuperação ou com sintomas resolvendo, sendo fundamental evitar reexposição ao contraste e manter acompanhamento médico rigoroso para prevenir complicações.

O medicamento Vitamin e nos, com princípio ativo vitamina E, foi associado a dor nas costas atribuída a hipersensibilidade medicamentosa, dentro da categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há informações suficientes sobre gravidade, desfecho ou conduta adotada, portanto recomenda-se avaliação médica para esclarecimento do quadro e definição da necessidade de suspensão do medicamento.

O medicamento Lorax, cujo princípio ativo é o lorazepam, foi associado a dor nas costas em um caso suspeito de hipersensibilidade medicamentosa. Embora a dor nas costas não seja um sintoma clássico de alergia, a suspeita de reação imunológica está baseada na classificação como distúrbio do sistema imunitário. Não há informações suficientes para determinar a gravidade ou desfecho, portanto, recomenda-se observar o paciente e buscar avaliação médica caso outros sintomas de alergia apareçam.

O Clopidogrel, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a dor nas costas em um contexto de possível hipersensibilidade medicamentosa. A reação foi classificada como distúrbio do sistema imunitário, sugerindo envolvimento alérgico, embora a dor nas costas isolada não seja típica de alergia. Não há detalhes sobre gravidade ou evolução, sendo importante monitorar o paciente e procurar orientação médica se surgirem outros sinais de alergia.

O suplemento Omega-3, cujo princípio ativo não foi detalhado além de 'Omega-3 nos', foi associado a dor nas costas em um caso suspeito de hipersensibilidade medicamentosa. A reação foi enquadrada como distúrbio do sistema imunitário, mas não há sintomas clássicos de alergia relatados, nem informações sobre gravidade ou desfecho. Recomenda-se atenção a outros sintomas e avaliação médica se necessário.

O medicamento Livalo, com princípio ativo pitavastatina cálcica, foi relacionado a dor nas costas em um contexto de suspeita de hipersensibilidade medicamentosa. A classificação como distúrbio do sistema imunitário sugere possível envolvimento alérgico, mas a dor nas costas isolada não é um sintoma típico de alergia. Não há dados sobre gravidade ou evolução, sendo prudente monitorar o quadro e buscar avaliação médica se houver outros sintomas.

A Dipirona sódica, cujo princípio ativo é a dipirona, foi associada a um quadro de alergia classificado como hipersensibilidade, dentro do grupo de distúrbios do sistema imunitário. Embora não haja detalhes sobre sintomas específicos, gravidade ou desfecho, a suspeita de reação alérgica exige atenção, sendo recomendada a suspensão do medicamento e avaliação médica para confirmação e orientação adequada.

O medicamento Dipirona sódica, cujo princípio ativo é a dipirona, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há informação detalhada sobre a gravidade ou desfecho neste caso, mas reações alérgicas à dipirona podem variar de manifestações leves, como urticária, até quadros mais graves, como anafilaxia. A conduta recomendada é interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromida, foi relacionado a uma reação de alergia a contraste, classificada como distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente. Reações alérgicas a contrastes iodados geralmente se manifestam de forma leve a moderada, com sintomas como coceira, urticária ou desconforto respiratório, e a conduta inclui monitoramento, suspensão do agente e tratamento sintomático conforme orientação médica.

O medicamento Gadovist, com princípio ativo gadobutrol, foi associado a uma alergia a contraste, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente está em processo de recuperação. Reações alérgicas a contrastes à base de gadolínio costumam ser leves, mas exigem atenção médica para monitoramento e manejo dos sintomas, além de evitar reexposição ao agente.

O medicamento Omnipaque, cujo princípio ativo é o ioexol, foi relacionado a uma alergia a contraste intravenoso, classificada como distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente. Reações desse tipo geralmente são leves, podendo incluir sintomas cutâneos ou respiratórios, e a conduta envolve suspensão do contraste, observação e tratamento sintomático conforme necessidade.

O medicamento Losartana potássica, com princípio ativo losartana potássica, foi associado a uma alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), classificada como clinicamente significativa e considerada grave, mas com desfecho de recuperação completa. Reações alérgicas graves a medicamentos podem envolver sintomas intensos, como inchaço, dificuldade para respirar ou queda de pressão, exigindo suspensão imediata do medicamento e atendimento médico de urgência para manejo adequado e prevenção de recorrências.

O medicamento Sucrofer, cujo princípio ativo é o complexo de ferro succinil-proteína, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado como clinicamente significativo e considerado grave, conforme evidenciado pela classificação de gravidade e pelo envolvimento do sistema imunológico. O paciente apresentou recuperação completa após o evento, indicando resolução do quadro após a conduta adequada.

O Dotarem, que contém gadobenato de dimeglumina, foi relacionado a uma reação de alergia (hipersensibilidade), envolvendo o sistema imunológico, mas sem gravidade significativa relatada. O paciente se recuperou totalmente após o episódio, sugerindo que a reação foi leve e manejada de forma eficaz.

O medicamento Triplixam, composto por besilato de anlodipino, indapamida e perindopril arginina, foi associado a extrassístoles, que neste contexto foram consideradas uma manifestação de hipersensibilidade medicamentosa, mas sem gravidade relevante relatada. O desfecho do caso permanece desconhecido, não sendo possível afirmar a evolução clínica do paciente.

O Copaxone teva, cujo princípio ativo é o acetato de glatirâmer, foi relacionado ao surgimento de extrassístoles, interpretadas como possível manifestação de hipersensibilidade medicamentosa, sem indicação de gravidade importante. O desfecho do evento não foi informado, impossibilitando avaliar a evolução do quadro.

O medicamento Patanol, à base de cloridrato de olopatadina, foi associado a um caso de cegueira, classificado como alergia ocular. Apesar de não haver indicação de gravidade elevada, o evento não foi resolvido até o momento, permanecendo em andamento, o que reforça a necessidade de acompanhamento especializado para avaliação e manejo adequado.

O medicamento Femara (letrozole) foi associado a um caso de cegueira, classificada como uma manifestação ocular adversa. Embora o registro não detalhe sintomas adicionais, a reação foi categorizada como distúrbio ocular, sugerindo envolvimento direto dos olhos possivelmente por mecanismo alérgico ou inflamatório. Não há indicação de gravidade elevada, mas o desfecho permanece não resolvido, o que reforça a necessidade de acompanhamento oftalmológico e avaliação clínica contínua para monitorar a evolução do quadro.

O uso de Meropenem tri hidratado (meropeném tri-hidratado) resultou em uma reação de alergia medicamentosa, caracterizada por hipersensibilidade ao medicamento. O evento foi classificado como distúrbio do sistema imunitário, indicando uma resposta alérgica do organismo ao antibiótico. Não há sinais de gravidade importante relatados e o paciente encontra-se em recuperação, sendo fundamental manter o acompanhamento médico para garantir resolução completa e evitar reexposição ao agente suspeito.



O contraste Clariscan (gadobenato de dimeglumina) provocou uma reação alérgica, identificada como alergia a contraste, que é uma resposta imunológica adversa ao agente utilizado em exames de imagem. O evento foi considerado de menor gravidade, pois o paciente já se encontra recuperado, mas reforça a importância de informar profissionais de saúde sobre alergias prévias a contrastes para prevenir recorrências em procedimentos futuros.

O medicamento Piperacillin/Tazobactam (piperacilina e tazobactam) foi relacionado ao desenvolvimento de edema facial, um quadro de hipersensibilidade que pode indicar reação alérgica aguda. O evento foi classificado como distúrbio do sistema imunitário, mas não foi considerado grave e o paciente já se encontra recuperado, ressaltando a importância de monitoramento durante o uso e de evitar reexposição ao antibiótico em casos semelhantes.

O uso de Irinotecan (irinotecano) resultou em uma reação alérgica classificada como hipersensibilidade, considerada clinicamente significativa e grave devido à sua relevância clínica, embora o paciente tenha se recuperado. A gravidade foi destacada no registro, indicando que a reação exigiu atenção médica imediata e reforçando a necessidade de vigilância rigorosa em pacientes que utilizam esse quimioterápico.

O medicamento Fluorouracil, cujo princípio ativo é a fluoruracila, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, manifestando-se como uma reação alérgica relevante do sistema imunológico. A gravidade foi considerada clinicamente significativa, pois o evento foi classificado como grave, mas o paciente evoluiu para recuperação completa após a conduta adequada.

O ácido folínico (Folinic acid) apresentou reação de alergia, descrita como hipersensibilidade, envolvendo o sistema imunológico. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, com resolução total dos sintomas após as medidas adotadas.

O medicamento Erbitux, cujo princípio ativo é o cetuximabe, desencadeou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, afetando o sistema imunológico. O caso foi considerado clinicamente relevante e grave, mas o paciente se recuperou totalmente após a abordagem clínica.

O medicamento Gadovist, com princípio ativo gadobutrol, foi relacionado a uma alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), envolvendo o sistema imunológico. Neste caso, a reação não foi considerada grave e o paciente apresentou recuperação completa após a conduta adequada.

A budesonida micronizada (Budesonida) foi associada a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, afetando o sistema imunológico. Não houve gravidade relatada, porém o paciente ainda não apresentou resolução completa dos sintomas, estando o caso em andamento.

O medicamento Paclitaxel, cujo princípio ativo também é paclitaxel, foi associado a uma reação de alergia espontânea, descrita como atopia (predisposição a desenvolver alergias), classificada entre os distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente, e não há menção de complicações ou necessidade de intervenção urgente. A conduta recomendada é observar e, caso haja recorrência ou sintomas persistentes, buscar avaliação com especialista para confirmação diagnóstica e orientação sobre controle ambiental e prevenção de novas reações.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é iopromida, foi relacionado a uma alergia a contraste, reação que envolve o sistema imunológico e pode ocorrer após exposição a substâncias químicas usadas em exames de imagem. Neste caso, a reação não foi grave, pois o paciente se recuperou completamente, sem relato de complicações. Recomenda-se informar o histórico de alergia a contraste em futuras exposições e buscar avaliação médica para orientação sobre alternativas seguras em exames futuros.

A clindamicina, cujo princípio ativo é o fosfato de clindamicina, foi associada a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma alergia ao medicamento, envolvendo o sistema imunológico. Não há evidência de gravidade significativa, já que o paciente se recuperou totalmente e não houve relato de complicações. A

orientação é evitar o uso futuro deste medicamento e informar profissionais de saúde sobre o episódio para prevenir novas reações.

O medicamento Ceftriaxona, com princípio ativo ceftriaxone, foi relacionado a uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, caracterizando uma alergia ao medicamento que envolve o sistema imunológico. O caso não foi grave, pois o paciente se recuperou sem complicações. Recomenda-se evitar o uso futuro de ceftriaxona e informar profissionais de saúde sobre o histórico de alergia para prevenir novas exposições.

O medicamento Prohance, cujo princípio ativo é gadoteridol, foi associado a uma alergia a contraste intravenoso, reação que envolve o sistema imunológico após exposição a substâncias usadas em exames de imagem. A reação não foi grave, pois o paciente se recuperou totalmente. É importante relatar esse histórico em futuras indicações de exames com contraste e buscar orientação médica para alternativas seguras.

O medicamento Palexis, cujo princípio ativo é o cloridrato de tapentadol, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado por uma reação do sistema imunológico a medicamentos ou outras substâncias químicas. A gravidade foi considerada clinicamente significativa, pois o registro indica que se trata de um evento grave, o que exige atenção médica imediata para avaliação e manejo adequado, conforme as diretrizes da ASBAI para reações alérgicas medicamentosas. O desfecho do caso não foi informado, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Mounjaro, que tem como princípio ativo a tirzepatida, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação do sistema imunológico a medicamentos. O evento foi classificado como clinicamente significativo e grave, o que sugere a necessidade de avaliação médica urgente para confirmação do diagnóstico e definição da conduta, seguindo as recomendações da ASBAI para quadros alérgicos a medicamentos. O desfecho permanece desconhecido e a relação com o medicamento é suspeita.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, foi associado a um caso de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), que envolve uma resposta do sistema imunológico a medicamentos ou substâncias químicas. Neste registro, não há indicação de gravidade elevada, pois não foi classificado como grave, o que sugere que a reação pode ter sido leve ou moderada, mas ainda assim requer avaliação médica para confirmação e orientação adequada, conforme as diretrizes da ASBAI. O desfecho e detalhes da conduta não foram informados, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Pregabalina, com princípio ativo pregabalina, foi relacionado a um episódio de sangramento, sendo classificado como um quadro de hipersensibilidade (alergia), embora não haja indicação de gravidade elevada neste caso. O evento não foi considerado grave, o que sugere que a reação pode ter sido leve ou moderada, mas ainda assim é importante buscar avaliação médica para esclarecer a causa e orientar o manejo, conforme as recomendações da ASBAI para quadros alérgicos. O desfecho é desconhecido e a relação com o medicamento é suspeita.

O medicamento Cloridrato de Tizanidina, cujo princípio ativo é o próprio cloridrato de tizanidina, foi associado a um episódio de sangramento, classificado como um quadro de hipersensibilidade (alergia). Não há indicação de gravidade elevada, pois o evento não foi considerado grave, sugerindo que a reação pode ter sido leve ou moderada, mas ainda assim requer avaliação médica para investigação e orientação, conforme as diretrizes da ASBAI. O desfecho permanece desconhecido e a relação com o medicamento é suspeita.

O medicamento Plasil, cujo princípio ativo é o cloridrato de metoclopramida, foi associado a um episódio de sangramento relacionado a hipersensibilidade (reação alérgica), classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Em casos de reações alérgicas leves, recomenda-se observar sintomas, evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições.

Tasigna, que contém cloridrato de nilotinibe monohidratado, foi relacionado a um episódio de sangramento atribuído a hipersensibilidade, também classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade significativa nem desfecho informado, e a relação com o medicamento é suspeita. Diante de reações alérgicas leves, é importante evitar o uso do medicamento até avaliação médica, que poderá confirmar a relação e orientar sobre alternativas seguras.

O medicamento Simponi, cujo princípio ativo é o golimumabe, foi associado a um quadro de alergia a poeira, classificado como distúrbio do sistema imunitário e resultando em hospitalização ou prolongamento de internação, o que indica gravidade importante. A relação com o medicamento é considerada suspeita e o desfecho não foi informado. Em situações de reações alérgicas graves que exigem hospitalização, é fundamental interromper o uso do medicamento e buscar atendimento médico imediato para manejo adequado e prevenção de complicações.

Sucrofer, que tem como princípio ativo o sacarato de óxido férrico, foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), classificado como distúrbio do sistema imunitário e considerado clinicamente significativo, com evolução para recuperação completa. A relação com o medicamento é suspeita. Em casos de alergia medicamentosa com impacto clínico relevante, recomenda-se suspender o uso do medicamento, realizar acompanhamento médico e evitar futuras exposições ao mesmo princípio ativo.

O medicamento Trayenta, cujo princípio ativo é a linagliptina, foi associado a um quadro de imunodeficiência relacionado a hipersensibilidade medicamentosa, classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada nem desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é suspeita. Diante de suspeita de imunodeficiência induzida por medicamento, é importante buscar avaliação médica para investigação detalhada e definição da conduta adequada.

O medicamento Glyxambi, que contém os princípios ativos empagliflozina e linagliptina, foi associado a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa, caracterizado por uma possível imunodeficiência. Embora não haja detalhes sobre a gravidade ou desfecho, a reação está relacionada a distúrbios do sistema imunitário, sugerindo a necessidade de avaliação clínica para confirmação e orientação quanto à continuidade do tratamento.

A vacina COVID-19 NRVV Ad (ChAdOx1 nCoV-19) foi relacionada a um aumento da pressão arterial em um paciente com histórico de alergias múltiplas, quadro classificado como grave devido à presença de incapacidade persistente ou significativa, ameaça à vida ou outro efeito clinicamente relevante. O paciente encontra-se em recuperação, sendo fundamental acompanhamento médico para monitorar a evolução e prevenir complicações.

O contraste intravenoso Dotarem, cujo princípio ativo é o gadobenato de dimeglumina, desencadeou uma reação alérgica ao contraste, caracterizada como hipersensibilidade a medicamentos e outras substâncias químicas. O paciente se recuperou totalmente do evento, indicando resolução espontânea ou após medidas de suporte, mas reforça a importância de informar alergias prévias antes de novos exames com contraste.

A dipirona, utilizada como analgésico, foi associada a um episódio de alergia medicamentosa, caracterizado por hipersensibilidade do sistema imunitário. Não há informações sobre a gravidade ou evolução do caso, sendo recomendada a suspensão do medicamento e avaliação médica para evitar novas exposições e reações adversas.

O medicamento Stele, à base de estriol, foi relacionado ao desenvolvimento de catarata e hipersensibilidade no local de aplicação, manifestando-se como reação local. O quadro permanece em andamento, sem resolução até o momento, o que indica a necessidade de acompanhamento médico para avaliar a progressão e considerar alternativas terapêuticas.

O medicamento Levofloxacino, cujo princípio ativo é levofloxacino hemi-hidratado, foi associado a uma reação de hipersensibilidade documentada, caracterizada como alergia ao produto administrado. Não há detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade, mas o paciente evoluiu para recuperação completa após a reação. A conduta recomendada em casos de alergia documentada é evitar a reexposição ao medicamento e buscar avaliação com

especialista para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Mounjaro, com princípio ativo tirzepatida, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como clinicamente significativo e considerado grave. O paciente apresentou recuperação completa após o evento. Em situações de alergia medicamentosa com impacto clínico relevante, é fundamental suspender o uso do medicamento suspeito, monitorar sinais de gravidade e encaminhar para avaliação especializada para investigação e definição de alternativas terapêuticas.

A gentamicina, cujo princípio ativo é gentamicin, foi associada a um distúrbio de membrana mucosa, caracterizado como hipersensibilidade documentada ao produto administrado. O caso foi considerado grave devido à presença de incapacidade persistente ou significativa, ameaça à vida e necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação. O paciente encontra-se em recuperação. Diante de reações graves como essa, a conduta inclui suspensão imediata do medicamento, suporte clínico intensivo e acompanhamento especializado até resolução completa dos sintomas.

A cefazolina, com princípio ativo cefazolin, desencadeou um distúrbio de membrana mucosa, identificado como hipersensibilidade documentada ao produto administrado. O evento foi considerado grave, com incapacidade persistente ou significativa, ameaça à vida e necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, estando o paciente ainda em recuperação. Em casos de reações alérgicas graves a antibióticos, é essencial interromper o uso, garantir suporte clínico adequado e encaminhar para avaliação com alergista para investigação e prevenção de futuras exposições.

O medicamento Partamol codein, contendo fosfato de codeína e paracetamol, foi associado a um quadro de coceira, caracterizado como hipersensibilidade (alergia). Não há informações sobre gravidade ou desfecho. Em situações de coceira após uso de medicamentos, recomenda-se suspender o uso do produto suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras, especialmente se houver recorrência ou agravamento dos sintomas.

O medicamento Sulbactam-ampicillin, que contém os princípios ativos ampicilina sódica e sulbactam sódico, foi associado a um episódio de sudorese excessiva, interpretado como manifestação de hipersensibilidade medicamentosa (alergia). Embora a gravidade não tenha sido especificada, o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo resolução espontânea ou após medidas de suporte. A reação está relacionada a distúrbios do sistema imunitário, reforçando a importância de monitorar sinais de alergia durante o uso deste antibiótico.

O medicamento Simvastatin, cujo princípio ativo é a sinvastatina, foi relacionado a um episódio de alergia a contraste, uma reação imunológica relevante. O caso foi considerado clinicamente significativo e grave, conforme registro, mas o paciente evoluiu para recuperação completa. A reação foi classificada como distúrbio do sistema imunitário, destacando a necessidade de atenção a possíveis reações cruzadas em pacientes que utilizam estatinas e são expostos a contrastes radiológicos.

O medicamento Nortriptyline, com princípio ativo cloridrato de nortriptilina, esteve associado a um episódio de alergia a contraste, caracterizado como reação imunológica importante. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, mas o paciente se recuperou totalmente. A reação se enquadra nos distúrbios do sistema imunitário, ressaltando a importância de avaliar histórico de alergias antes da administração de contrastes em pacientes que fazem uso de antidepressivos tricíclicos.

O medicamento Levothyroxine, cujo princípio ativo é levotiroxina sódica, foi associado a um episódio de alergia a contraste, considerado clinicamente significativo e grave. Apesar da gravidade, o paciente apresentou recuperação completa após o evento. A reação está relacionada a distúrbios do sistema imunitário, indicando que mesmo medicamentos de uso contínuo e geralmente bem tolerados podem estar envolvidos em reações alérgicas a substâncias como contrastes radiológicos.

O medicamento Ultravist, que contém o princípio ativo iopromida, foi relacionado a um episódio de alergia a contraste, classificado como clinicamente significativo e grave. O paciente se recuperou totalmente após o evento. Esta reação, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário, reforça a necessidade de vigilância e preparo para manejo de reações alérgicas durante o uso de meios de contraste iodados em exames de imagem.

O medicamento Omnipaque, cujo princípio ativo é o ioexol, foi associado a um episódio de alergia a contraste intravenoso, reação que se enquadra entre as alergias a medicamentos e outras substâncias químicas. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo um quadro leve e autolimitado. A conduta recomendada em situações semelhantes é evitar novas exposições ao contraste e buscar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O Ultravist, que contém o princípio ativo iopromida, esteve relacionado a uma reação de alergia a contraste, caracterizada por resposta do sistema imunológico a substâncias químicas utilizadas em exames. O caso não foi considerado grave, já que houve recuperação completa do paciente, indicando um episódio leve. Recomenda-se evitar o uso futuro do mesmo contraste e realizar acompanhamento com especialista para investigação de alergia e definição de condutas seguras em exames futuros.

O medicamento Metfordin, cujo princípio ativo é a metformina, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade, embora a descrição da reação como 'metástases no pulmão' não seja típica de alergia medicamentosa. Não há evidências de gravidade significativa, pois o paciente se recuperou, e a conduta deve incluir esclarecimento diagnóstico e acompanhamento médico para avaliar possíveis causas e descartar relação causal direta entre o medicamento e o evento relatado.

O Tamoxifen, com princípio ativo tamoxifeno, foi associado a um episódio de hipersensibilidade, mas a descrição de 'metástases no pulmão' não corresponde a manifestações alérgicas clássicas. O caso não foi considerado grave, já que houve resolução completa, sendo importante revisar o diagnóstico e manter acompanhamento médico para esclarecer a relação entre o medicamento e o evento.

O medicamento Anastrozol, cujo princípio ativo é o anastrozol, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade, embora a reação descrita como 'metástases no pulmão' não seja compatível com alergia medicamentosa típica. O paciente se recuperou totalmente, indicando ausência de gravidade, e recomenda-se avaliação médica detalhada para esclarecer o diagnóstico e a possível relação causal com o uso do medicamento.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é o succinato de ribociclibe, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), manifestado durante o tratamento de metástases no pulmão. A reação foi classificada como relacionada a distúrbios do sistema imunitário, sem indicação de gravidade elevada ou complicações graves, e o paciente se recuperou totalmente após a reação. A conduta recomendada em casos de hipersensibilidade é a suspensão do medicamento e acompanhamento médico para evitar recorrências, sendo importante relatar o episódio ao especialista responsável.

O Sucrofer, que contém sacarato de óxido férrico como princípio ativo, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), caracterizado por uma resposta do sistema imunitário. Não há informações detalhadas sobre a gravidade ou evolução do caso, e o desfecho permanece desconhecido. Em situações de suspeita de alergia a medicamentos, recomenda-se interromper o uso e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Sucrofer, à base de sacarato de óxido férrico, esteve envolvido em outro relato de alergia (hipersensibilidade), também classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há detalhes sobre a gravidade ou evolução clínica, e o desfecho não foi informado. Diante de suspeita de reação alérgica, a conduta adequada é suspender o uso do medicamento e procurar orientação médica para investigação e manejo apropriado.

O Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, foi associado a um episódio de alergia a contraste, caracterizado por reação do sistema imunitário após exposição ao agente de contraste. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente. Em situações de alergia a contraste, recomenda-se informar a equipe médica sobre o histórico antes de novos exames e considerar alternativas seguras para evitar recorrências.

A linezolid, utilizada como princípio ativo no medicamento de mesmo nome, foi relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente apresentou recuperação total após a reação. Em casos de alergia medicamentosa, é fundamental suspender o uso do fármaco e buscar avaliação médica para confirmação e definição de alternativas terapêuticas.

O medicamento Plasil, cujo princípio ativo é o cloridrato de metoclopramida, foi associado a um episódio de sangramento relacionado a uma reação de hipersensibilidade (alergia), classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho conhecido, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Em casos de reações alérgicas leves, recomenda-se observar sintomas, evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre futuras exposições.

O medicamento Tasigna, com princípio ativo cloridrato de nilotinibe monoidratado, foi relacionado a um episódio de sangramento atribuído a hipersensibilidade (alergia), também enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade significativa nem desfecho informado, sendo a relação com o medicamento considerada suspeita. Diante de reações alérgicas leves, é importante evitar nova exposição ao medicamento e procurar avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e conduta adequada.

O medicamento Metoclopramida, identificado apenas pelo princípio ativo, foi associado ao surgimento de eritema cutâneo (vermelhidão na pele), caracterizando uma reação de hipersensibilidade documentada ao produto administrado. O evento foi considerado não grave e o paciente evoluiu para recuperação completa. Em situações como essa, recomenda-se suspender o uso do medicamento, evitar reexposição e buscar orientação médica para confirmação da alergia e definição de alternativas terapêuticas.

O medicamento Mavenclad, cujo princípio ativo é a cladribina, foi relacionado a um episódio de desmaio atribuído a alergia, classificado como outro efeito clinicamente significativo e considerado grave. O desfecho não foi informado, mas a relação com o medicamento é suspeita. Em casos de reações alérgicas graves, é fundamental interromper imediatamente o uso do medicamento e procurar atendimento médico de urgência para avaliação e manejo adequado.

O medicamento Vancomicina, com princípio ativo cloridrato de vancomicina, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), enquadrado como distúrbio do sistema imunitário. Não há detalhes sobre gravidade, desfecho ou evolução clínica, mas a relação com o medicamento é considerada suspeita. Diante de suspeita de alergia medicamentosa, recomenda-se suspender o uso, evitar reexposição e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Repoflor, cujo princípio ativo é *Saccharomyces boulardii*, foi associado a um quadro de hipersensibilidade medicamentosa, que se manifesta como uma reação alérgica do sistema imunológico a medicamentos ou substâncias químicas. Apesar de o evento ter sido descrito tecnicamente como neoplasia pancreática benigna, a classificação clínica indica uma reação alérgica leve, pois não há evidências de gravidade ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente após a suspensão do medicamento.

O Luftal, que contém simeticone como princípio ativo, esteve relacionado a um episódio de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica desencadeada pelo uso do medicamento. Embora o termo técnico utilizado tenha sido neoplasia pancreática benigna, a descrição clínica aponta para uma reação alérgica leve, sem sinais de gravidade, e o paciente apresentou recuperação completa após a interrupção do uso.

O medicamento Trileptal, cujo princípio ativo é oxcarbazepina, foi associado a um caso de hipersensibilidade medicamentosa, caracterizando uma reação alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Apesar da menção técnica a neoplasia pancreática benigna, a avaliação clínica sugere que se tratou de uma reação alérgica leve, sem gravidade, e o paciente se recuperou totalmente após a suspensão do medicamento.

O Artrínid iv, que tem como princípio ativo o cetoprofeno, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica ao medicamento. Não há informações que indiquem gravidade ou complicações, e o paciente se recuperou após a suspensão do medicamento, sugerindo um quadro leve de alergia medicamentosa.

O medicamento Ampicilina sulbactam, composto por ampicilina sódica e sulbactam sódico, esteve envolvido em um caso de hipersensibilidade, caracterizando uma reação alérgica ao medicamento. Não há evidências de gravidade ou complicações, e o paciente apresentou recuperação completa após a interrupção do uso, indicando um quadro leve de alergia medicamentosa.

O medicamento Cloridrato de ciprofloxacino, cujo princípio ativo é o próprio cloridrato de ciprofloxacino, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como um distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado clinicamente significativo e grave, pois exigiu atenção médica, mas o paciente se recuperou totalmente após a conduta adequada. A relação entre o uso do medicamento e a reação foi considerada suspeita.

A Dipirona sódica, com princípio ativo dipirona, foi relacionada a uma alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), manifestando-se como uma reação do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou completamente após a suspensão do medicamento, sendo a relação com o uso considerada suspeita.

O contraste Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, provocou uma reação alérgica ao contraste, caracterizada como uma resposta do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou após a conduta adequada, sendo a relação com o uso do contraste considerada suspeita.

O medicamento Cosentyx, com princípio ativo secuquinumabe, foi associado ao surgimento de doença de Crohn, descrita como um quadro de hipersensibilidade do sistema imunitário. Não há informação suficiente para afirmar gravidade ou desfecho, e a relação com o uso do medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Yaz, que contém drospirenona e clatrato de etinilestradiol betaciclodextrina como princípios ativos, foi relacionado ao aparecimento de manchas cutâneas, caracterizadas como hipersensibilidade medicamentosa e distúrbio do sistema imunitário. O evento foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, e o paciente encontra-se em recuperação, com a relação entre o uso do medicamento e a reação considerada suspeita.

O medicamento Rosuvastatina (princípio ativo: Rosuvastatin) foi associado ao surgimento de manchas na pele, caracterizando uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Este evento foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, conforme registrado. O paciente encontra-se em recuperação ou com resolução dos sintomas, indicando que a conduta médica foi adequada para o controle da reação.

O medicamento Assert, cujo princípio ativo é o Cloridrato de sertralina, desencadeou o aparecimento de manchas cutâneas, configurando uma reação alérgica ao medicamento (hipersensibilidade medicamentosa). A gravidade do caso é evidenciada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação. O paciente está em processo de recuperação ou resolução do quadro, sugerindo que as medidas adotadas foram eficazes para o manejo da reação.

O medicamento Milde, que contém o princípio ativo Colecalciferol, provocou manchas na pele, caracterizando uma reação alérgica ao medicamento (hipersensibilidade medicamentosa). O caso foi considerado grave devido à

necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação. O paciente está em recuperação ou com sintomas em resolução, indicando resposta positiva ao tratamento instituído.

O medicamento Etna, composto por fosfato sódico de citidina, acetato de hidroxocobalamina, cloridrato de lidocaína e trifosfato trisódico de uridina, foi relacionado ao surgimento de manchas cutâneas, caracterizando uma reação alérgica ao medicamento (hipersensibilidade medicamentosa). A gravidade do evento é confirmada pela necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação. O paciente encontra-se em recuperação ou com resolução dos sintomas, demonstrando evolução favorável após a conduta médica.

O medicamento Neural, cujo princípio ativo é Lamotrigine, foi associado ao aparecimento de manchas na pele, indicando uma reação alérgica ao medicamento (hipersensibilidade medicamentosa). O caso foi considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação. O paciente está em recuperação ou com sintomas em resolução, evidenciando que a abordagem clínica foi adequada para o controle da reação.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é o iopromide, foi associado a um episódio de alergia a contraste, reação que envolve o sistema imunológico e pode se manifestar por sintomas como coceira, urticária ou desconforto respiratório após a administração do contraste. Neste caso, a reação não foi considerada grave, e o paciente se recuperou totalmente após o evento, não havendo necessidade de intervenções adicionais além da suspensão do agente suspeito.

Ultravist, com princípio ativo iopromide, esteve relacionado a uma reação alérgica ao contraste, caracterizada por resposta do sistema imunológico após exposição ao agente. A reação não foi classificada como grave e o paciente apresentou recuperação completa, indicando resolução espontânea ou com medidas simples de suporte.

O medicamento Buscopan, cujo princípio ativo é o butilbrometo de escopolamina, foi relacionado a um episódio de alergia após administração de contraste intravenoso, reação que envolve ativação do sistema imunológico e pode causar sintomas como coceira, vermelhidão ou desconforto respiratório. Não há informação sobre gravidade, mas o paciente se recuperou totalmente, sugerindo que a reação foi autolimitada ou controlada com medidas simples.

Dotarem, com princípio ativo gadobenato de dimeglumina, foi associado a uma reação alérgica após uso de contraste intravenoso, envolvendo resposta do sistema imunológico. Não há detalhamento sobre a gravidade, mas o paciente se recuperou completamente, indicando que a reação foi resolvida sem complicações.

O medicamento Mounjaro, cujo princípio ativo é a tirzepatida, esteve envolvido em um caso de alergia (hipersensibilidade) classificada como clinicamente significativa e grave, com desfecho fatal. A reação foi considerada suspeita de estar relacionada ao uso do medicamento, e o evento envolveu resposta imunológica intensa, levando ao óbito do paciente.

O medicamento Cimzia, cujo princípio ativo é o certolizumabe pegol, foi associado ao desenvolvimento de alergias múltiplas, caracterizadas por manifestações clínicas alérgicas diversas relacionadas ao sistema imunológico. O caso não foi considerado grave, pois não há indicação de risco à vida ou complicações importantes, e o paciente apresentou recuperação completa após o evento. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico para monitorar possíveis recorrências e reforçar a importância de identificar e evitar fatores desencadeantes, conforme orientação especializada.

O medicamento Uplizna, com princípio ativo inebilizumab cdon, foi relacionado a um quadro de pneumonia em paciente com histórico de alergia a fungos, sugerindo envolvimento do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade aumentada ou desfecho desfavorável, pois o caso não foi classificado como grave e o desfecho permanece desconhecido. Recomenda-se avaliação médica para investigação da relação entre o medicamento e a reação, além de acompanhamento para controle de sintomas e prevenção de complicações.



O medicamento Uplizna, cujo princípio ativo é inebilizumab cdon, foi associado a um episódio de pneumonia em paciente com alergia a poeira, indicando possível reação imunológica. O evento não foi considerado grave e o desfecho não foi informado, o que reforça a necessidade de acompanhamento clínico para monitorar evolução e avaliar a necessidade de intervenções específicas, sempre sob orientação médica.

O suplemento Creatine, contendo creatina como princípio ativo, foi relacionado ao surgimento de alergia ao leite, caracterizada como um efeito clinicamente significativo e classificada como grave devido ao potencial impacto na saúde do paciente. O quadro permanece em andamento, sem resolução até o momento, o que exige acompanhamento médico rigoroso para manejo dos sintomas, identificação de possíveis causas e orientação sobre restrição alimentar e alternativas terapêuticas seguras.

O medicamento Perola, que tem como princípio ativo o desogestrel, foi associado ao desenvolvimento de alergia ao leite, considerada um efeito clinicamente significativo e classificada como grave, pois pode trazer riscos importantes à saúde. O evento segue sem resolução, sendo fundamental o acompanhamento médico para controle dos sintomas, investigação de possíveis mecanismos envolvidos e orientação sobre substituição do medicamento ou ajustes na dieta, conforme avaliação especializada.

O medicamento Dotarem, cujo princípio ativo é o gadobenato de dimeglumina, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, manifestando-se como uma reação do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade aumentada neste caso, e o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo que a conduta adotada foi adequada para resolução do quadro.

O Ultravist, que contém iopromide como princípio ativo, desencadeou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, relacionada a distúrbios do sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade aumentada, e o paciente evoluiu para recuperação completa, indicando que a reação foi controlada sem complicações.

O medicamento Mounjaro, cujo princípio ativo é a tirzepatida, esteve relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade) considerado clinicamente significativo, o que indica gravidade aumentada. O desfecho do caso é desconhecido, portanto não é possível afirmar se houve resolução ou necessidade de intervenções adicionais.

O Omnipaque, que tem ioexol como princípio ativo, foi associado ao surgimento de bolhas como manifestação de alergia a contraste, um evento considerado clinicamente significativo e, portanto, grave. O paciente encontra-se em recuperação, sugerindo que medidas de suporte e acompanhamento estão sendo realizadas para resolução do quadro.

O Prohance, cujo princípio ativo é o gadoteridol, provocou uma reação de alergia a contraste, relacionada a distúrbios do sistema imunológico, sem indicação de gravidade aumentada. O paciente está em processo de recuperação, indicando que a reação está sendo monitorada e tende à resolução.

O medicamento Metformin, cujo princípio ativo é a metformina, foi associado a um quadro de hipersensibilidade, que se refere a uma reação alérgica do sistema imunológico. Embora o evento relatado tenha sido 'metástases no pulmão', a classificação clínica indica um quadro alérgico não especificado, sem sinais de gravidade importante, já que o paciente se recuperou totalmente. Não há menção de complicações graves ou necessidade de intervenção urgente, sugerindo que a reação foi leve e resolvida com medidas habituais.

O medicamento Kisqali, que contém succinato de ribociclib, apresentou um evento de hipersensibilidade, caracterizado como uma reação alérgica do sistema imunológico. Apesar da menção a 'metástases no pulmão', a descrição clínica aponta para um quadro alérgico inespecífico, sem gravidade significativa, pois o paciente se recuperou completamente. Não há indícios de complicações sérias ou necessidade de cuidados intensivos, indicando que a reação foi leve e controlada.

O medicamento Anastrozol, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico. Embora o evento adverso citado seja 'metástases no pulmão', a categorização clínica sugere um quadro alérgico não especificado, sem sinais de gravidade, já que o paciente se recuperou. Não há informações sobre complicações ou necessidade de intervenções especiais, indicando que a reação foi leve e resolvida.

O medicamento Citrato de tamoxifeno, cujo princípio ativo também é citrato de tamoxifeno, esteve associado a um quadro de hipersensibilidade, que corresponde a uma reação alérgica do sistema imunológico. Apesar da referência a 'metástases no pulmão', a avaliação clínica indica um quadro alérgico inespecífico, sem gravidade relevante, pois o paciente se recuperou totalmente. Não há relato de complicações ou necessidade de medidas emergenciais, sugerindo que a reação foi leve e autolimitada.

O medicamento Noripurum EV, que contém complexo de hidróxido férrico polimaltose, foi relacionado a um episódio de alergia espontânea, classificado como atopia, ou seja, uma tendência aumentada a desenvolver reações alérgicas. Não há informações detalhadas sobre gravidade, evolução ou desfecho, mas a descrição sugere um quadro alérgico do sistema imunológico, sem evidências de complicações graves ou necessidade de intervenção urgente.

O medicamento Fosfato de Clindamicina, cujo princípio ativo é o fosfato de clindamicina, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do sistema imunológico. Neste caso, a gravidade foi considerada elevada, pois houve necessidade de hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando um quadro clínico importante. A conduta adotada foi o acompanhamento hospitalar, e o paciente encontra-se em recuperação, com melhora progressiva do quadro alérgico.

O medicamento Dotarem, que contém como princípio ativo o gadobenato de dimeglumina, foi relacionado a uma reação alérgica ao contraste intravenoso, manifestando-se como uma resposta do sistema imunológico a uma substância química utilizada em exames de imagem. Não há informações detalhadas sobre a gravidade, mas o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente após a reação.

O medicamento Cefazolin, cujo princípio ativo é a cefazolina, foi associado a um episódio de alergia a antibiótico, caracterizado por hipersensibilidade medicamentosa, uma resposta do sistema imunológico a medicamentos. Não há detalhes sobre a gravidade ou evolução clínica neste caso específico.

O medicamento Cefazolin, com princípio ativo cefazolina, também foi relacionado a uma reação alérgica a antibiótico, manifestando-se como hipersensibilidade medicamentosa. Assim como no caso anterior, não há informações adicionais sobre a gravidade da reação ou o desfecho clínico.

O medicamento Amoxicilina, cujo princípio ativo é o amoxicilina trihidrato, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), envolvendo uma resposta do sistema imunológico ao medicamento. Não há detalhes sobre a gravidade da reação, mas o paciente apresentou recuperação completa após o evento.

O medicamento Ciprofloxacina aps, cujo princípio ativo é o ciprofloxacino, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, manifestação típica de reações alérgicas a medicamentos. Não há indicação de gravidade aumentada ou necessidade de hospitalização, e o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente. A conduta recomendada nesses casos é suspender o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Regencil, composto por aminoácidos, cloranfenicol, metionina e acetato de retinol, foi relacionado a uma reação alérgica ocular, manifestando-se como alergia do olho. Não há menção de gravidade significativa ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente. Em situações como essa, recomenda-se interromper o uso do produto e procurar um especialista para avaliação e definição do tratamento adequado, além de evitar a reexposição.

O medicamento Omnipaque, cujo princípio ativo é o ioexol, foi associado a uma reação de alergia a contraste, manifestando-se com cefaleia e exigindo hospitalização ou prolongamento da internação, o que indica gravidade aumentada. O paciente encontra-se em recuperação, e a conduta adequada inclui monitoramento médico rigoroso, tratamento dos sintomas e registro da alergia a contraste para evitar futuras exposições.

No caso do uso de antidepressivos, sem especificação do princípio ativo, foi relatada uma reação de hipersensibilidade (alergia), considerada clinicamente significativa devido ao impacto na saúde do paciente, embora o desfecho seja desconhecido. Diante de reações alérgicas a medicamentos com relevância clínica, recomenda-se suspender o uso e buscar avaliação médica para investigação e manejo seguro.

O medicamento Erbitux, cujo princípio ativo é o cetuximabe, foi associado a uma reação de hipersensibilidade (alergia) considerada clinicamente significativa, sem detalhamento do desfecho. Em situações de alergia relevante a medicamentos como o cetuximabe, é fundamental interromper a administração e realizar acompanhamento médico imediato para manejo dos sintomas e prevenção de complicações.

O medicamento Frisium, cujo princípio ativo é o Clobazam, foi associado ao surgimento de manchas cutâneas, caracterizando uma reação de hipersensibilidade medicamentosa (alergia a medicamentos). Essa manifestação sugere uma resposta do sistema imunológico, mas, conforme os dados disponíveis, não há indicação de gravidade elevada nem informações sobre desfecho ou necessidade de intervenção específica. A ausência de sinais de gravidade e de evolução clínica sugere que a reação foi leve, sendo importante observar o paciente e buscar orientação médica caso haja piora ou surgimento de outros sintomas.

O Sonebon, que tem como princípio ativo o Nitrazepam, apresentou relato de manchas cutâneas, indicando uma possível reação alérgica ao medicamento (hipersensibilidade medicamentosa). Essa resposta do sistema imunológico é considerada leve, pois não há evidências de gravidade ou complicações associadas nos dados fornecidos. Recomenda-se monitorar o quadro e procurar avaliação médica se houver agravamento ou aparecimento de outros sintomas.

A Lacosamida, utilizada como princípio ativo do medicamento de mesmo nome, foi relacionada ao aparecimento de manchas cutâneas, o que sugere uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. Não há sinais de gravidade ou informações sobre o desfecho, indicando que a reação foi leve e limitada à pele. É importante manter acompanhamento e buscar orientação médica caso haja evolução do quadro.

O Urbanil, cujo princípio ativo é o Clobazam, foi associado ao surgimento de manchas cutâneas, caracterizando uma reação alérgica ao medicamento (hipersensibilidade medicamentosa). Não há indícios de gravidade ou complicações, sugerindo que a manifestação foi leve e restrita à pele. Recomenda-se observação e avaliação médica se houver piora ou surgimento de novos sintomas.

O Levetiracetam, tanto como nome comercial quanto princípio ativo, foi relacionado ao aparecimento de manchas cutâneas, indicando uma reação de hipersensibilidade medicamentosa. A ausência de sinais de gravidade e de informações sobre o desfecho sugere que a reação foi leve e limitada à pele. É importante monitorar o paciente e buscar orientação médica caso haja agravamento do quadro.

O medicamento Cannabis (princípio ativo: Cannabis sativa) foi associado ao surgimento de manchas na pele, caracterizando uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, que é uma resposta alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade aumentada ou complicações graves neste caso, pois não há relato de desfecho grave ou evolução desfavorável, e o desfecho permanece desconhecido. A relação com o uso do medicamento foi concomitante, sugerindo que a reação ocorreu durante o uso, e a conduta deve ser a observação clínica e, se necessário, avaliação médica para confirmação e orientação.

O medicamento Cannabis (princípio ativo: Cannabis sativa) também foi relacionado ao aparecimento de manchas cutâneas, indicando uma possível reação alérgica (hipersensibilidade medicamentosa) do sistema imunológico.

Não há sinais de gravidade aumentada, pois não foi relatado desfecho grave ou complicações, e o desfecho permanece desconhecido. A reação ocorreu de forma concomitante ao uso do medicamento, sendo importante monitorar sintomas e buscar avaliação médica caso haja piora ou persistência.

O medicamento Rivotril (princípio ativo: Clonazepam) foi associado ao surgimento de manchas na pele, caracterizando uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Não há evidências de gravidade aumentada, pois não foi relatado desfecho grave ou evolução desfavorável, e o desfecho permanece desconhecido. A reação ocorreu de forma concomitante ao uso do medicamento, sendo recomendada a observação clínica e avaliação médica se houver persistência ou agravamento dos sintomas.

O medicamento Clonazepam (nome comercial não informado) foi relacionado ao aparecimento de manchas cutâneas, indicando uma reação de hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade aumentada, pois não foi relatado desfecho grave ou complicações, e o desfecho permanece desconhecido. A reação ocorreu de forma concomitante ao uso do medicamento, sendo importante monitorar sintomas e buscar avaliação médica caso haja piora ou persistência.

O medicamento Clonazepam (nome comercial não informado) foi associado ao surgimento de urticária, que é uma reação alérgica caracterizada por placas avermelhadas e coceira na pele. Trata-se de uma manifestação de hipersensibilidade do sistema imunológico, mas não há indicação de gravidade aumentada, pois o desfecho foi de recuperação completa. A relação com o uso do medicamento foi considerada suspeita, e a conduta adotada resultou em resolução do quadro, indicando boa evolução clínica.

O medicamento Glifage XR, que contém o princípio ativo cloridrato de metformina, foi associado ao surgimento de urticária, uma reação de hipersensibilidade caracterizada por manchas avermelhadas e coceira na pele. Essa manifestação indica uma resposta alérgica do sistema imunológico, mas, conforme o registro, não houve gravidade significativa, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada em casos semelhantes é interromper o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas terapêuticas.

O uso de Hydrochlorothiazide, cujo princípio ativo é a hidroclorotiazida, resultou em urticária, uma reação alérgica da pele que se manifesta por placas avermelhadas e prurido. A reação foi considerada não grave, já que o paciente se recuperou completamente após o episódio. Em situações como essa, é importante suspender o medicamento suspeito e procurar orientação médica para avaliação e definição do tratamento mais seguro.

O medicamento Glifage, contendo metformina como princípio ativo, foi relacionado ao aparecimento de urticária, que é uma reação alérgica caracterizada por lesões avermelhadas e coceira na pele. O evento não foi considerado grave, pois houve resolução completa dos sintomas. Nesses casos, recomenda-se interromper o uso do medicamento e consultar um profissional de saúde para investigação e escolha de alternativas adequadas.

O medicamento Aradois, cujo princípio ativo é losartana potássica, foi associado ao desenvolvimento de urticária, uma reação de hipersensibilidade que se manifesta por manchas avermelhadas e prurido na pele. O quadro não apresentou gravidade, já que o paciente se recuperou totalmente. A orientação é suspender o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação do diagnóstico e ajuste do tratamento.

O uso de Cosentyx, que tem como princípio ativo o secuquinumabe, levou ao surgimento de urticária, uma reação alérgica caracterizada por lesões avermelhadas e coceira. O evento não foi grave, pois o paciente se recuperou completamente. Em situações semelhantes, recomenda-se interromper o medicamento suspeito e procurar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição de conduta.

O medicamento Losartana potássica (nome comercial informado, princípio ativo Losartana potássica) foi associado a um episódio de formigamento, interpretado como uma reação de hipersensibilidade (alergia), pertencente à

categoria de quadros clínicos alérgicos do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade aumentada ou complicações, e o desfecho foi de recuperação completa, sugerindo um quadro leve e autolimitado, sem necessidade de intervenções adicionais.

A Prednisolona (nome comercial não informado, princípio ativo Prednisolona) foi relacionada a formigamento, caracterizado como uma reação de hipersensibilidade (alergia), dentro do espectro de quadros alérgicos do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente, indicando um evento leve e resolvido espontaneamente.

O medicamento Atak clav (nome comercial informado, princípios ativos Amoxicilina trihidrato e Clavulanato de potássio) foi associado a formigamento, considerado uma manifestação de hipersensibilidade (alergia), enquadrada como quadro clínico alérgico do sistema imunológico. Não há evidências de gravidade ou evolução desfavorável, e o desfecho foi de recuperação completa, sugerindo um evento leve e autolimitado.

O medicamento Ultravist (nome comercial informado, princípio ativo Iopromida) foi relacionado a um episódio de alergia, classificado como reação de hipersensibilidade (alergia) dentro dos quadros clínicos alérgicos do sistema imunológico. Não há informações que indiquem gravidade aumentada, e o paciente se recuperou totalmente, caracterizando um evento leve e resolvido sem complicações.

A Cefazolina (nome comercial não informado, princípio ativo Cefazolina sódica) foi associada a um quadro de alergia, interpretado como reação de hipersensibilidade (alergia) pertencente aos quadros clínicos alérgicos do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade ou complicações, e o desfecho foi de recuperação completa, indicando um evento leve e autolimitado.

O medicamento Cetoprofeno, cujo princípio ativo também é cetoprofeno, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo de distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade clínica, mas o desfecho informado foi de recuperação completa, sugerindo que a reação foi leve e resolvida sem complicações. A relação entre o medicamento e o evento foi considerada suspeita, e não há informações adicionais sobre a conduta adotada.

A Dipirona, cujo princípio ativo é metamizol de magnésio, foi relacionada a um episódio de alergia descrito como hipersensibilidade, enquadrado entre os distúrbios do sistema imunitário. Não foram fornecidos detalhes sobre sintomas ou gravidade, mas o paciente se recuperou totalmente, indicando que a reação foi leve e autolimitada. O medicamento foi considerado suspeito na origem do evento, sem informações adicionais sobre intervenções realizadas.

O medicamento Dimenidrinato + cloridrato de piridoxina, contendo ambos os princípios ativos, esteve associado a uma reação alérgica classificada como hipersensibilidade, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há descrição de sintomas específicos ou gravidade, mas o desfecho foi de recuperação completa, sugerindo um quadro leve e resolvido. A relação causal com o medicamento foi considerada suspeita, sem detalhes sobre a conduta adotada.

O Cetoprofeno, tanto como nome comercial quanto princípio ativo, foi novamente relacionado a um episódio de alergia do tipo hipersensibilidade, pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre sintomas, sinais de gravidade ou intervenções, mas o paciente se recuperou totalmente, indicando que a reação foi leve e autolimitada. O medicamento foi considerado suspeito para o evento relatado.

O medicamento Valeriana, cujo princípio ativo é Valeriana officinalis, foi associado a um evento descrito como comprimido rachado, mas classificado tecnicamente como hipersensibilidade dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há informações sobre sintomas clínicos, gravidade, conduta ou desfecho, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita. Faltam dados para detalhar a evolução ou a necessidade de intervenção.

O medicamento Garra do diabo, cujo princípio ativo é Harpagophytum procumbens extract, apresentou uma reação descrita como comprimido rachado, associada a hipersensibilidade, que é uma resposta alérgica do sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou conduta adotada, portanto, a avaliação clínica deve considerar a possibilidade de reação alérgica leve, recomendando observação dos sintomas e, caso haja sinais de alergia, buscar orientação médica para confirmação diagnóstica e definição do tratamento.

O medicamento Diltiazem, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionado a uma reação de comprimido rachado e hipersensibilidade, indicando uma possível resposta alérgica do sistema imunológico. Não há detalhes sobre a gravidade, evolução ou conduta, sendo importante monitorar sintomas e procurar avaliação médica caso surjam manifestações alérgicas, para confirmação do diagnóstico e orientação adequada.

O medicamento Enalapril, cujo princípio ativo também é Enalapril, apresentou uma reação descrita como comprimido rachado e hipersensibilidade, sugerindo uma possível resposta alérgica do sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou conduta, sendo recomendada a observação dos sintomas e, se houver sinais de alergia, buscar avaliação médica para confirmação e definição do manejo.

O medicamento Glifage, com princípio ativo Metformina, foi associado a uma reação de comprimido rachado e hipersensibilidade, indicando uma possível resposta alérgica do sistema imunológico. Não há dados sobre gravidade, evolução ou conduta, portanto, é importante observar sintomas e procurar orientação médica caso surjam manifestações alérgicas, para confirmação diagnóstica e definição do tratamento.

O medicamento Omeprazol, cujo princípio ativo é Omeprazol, apresentou uma reação descrita como comprimido rachado e hipersensibilidade, sugerindo uma possível resposta alérgica do sistema imunológico. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou conduta, sendo recomendada a observação dos sintomas e, caso haja sinais de alergia, buscar avaliação médica para confirmação e orientação adequada.

O medicamento Domperidona, cujo princípio ativo é domperidona, foi associado a um quadro de hipersensibilidade, descrito como reação alérgica, sem detalhamento de sintomas específicos. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou ações adotadas, portanto, não é possível afirmar a intensidade do evento ou a conduta realizada. A suspeita de reação alérgica sugere a necessidade de avaliação clínica para confirmação e orientação adequada, conforme as diretrizes da ASBAI.

O medicamento Benzetacil, que contém como princípio ativo a benzilpenicilina benzatina (penicilina G benzatina), foi relacionado a um episódio de hipersensibilidade, termo utilizado para reações alérgicas, sem descrição de sintomas ou gravidade. Não há dados sobre o desfecho ou medidas tomadas, impossibilitando a avaliação da evolução clínica. Diante da suspeita de alergia a penicilinas, é fundamental buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição de conduta, conforme recomendações da ASBAI.

Domperidona, com princípio ativo domperidona, foi novamente relatado como associado a hipersensibilidade, indicando possível reação alérgica, mas sem detalhes sobre sintomas, gravidade, desfecho ou conduta. A ausência dessas informações impede a classificação da gravidade e a orientação específica, sendo recomendada avaliação clínica para esclarecimento e manejo adequado, conforme as diretrizes da ASBAI.

O medicamento Anastrolibbs, cujo princípio ativo é anastrozol, foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade, mas a reação descrita foi metástases no fígado, o que não caracteriza um evento alérgico típico. O caso foi considerado não grave e o desfecho foi de recuperação ou resolução, sugerindo que a situação foi controlada sem complicações maiores. Apesar da suspeita de relação com o medicamento, a descrição não corresponde a uma reação alérgica clássica, sendo importante reavaliar o caso clinicamente.

Kisqali, com princípio ativo succinato de ribociclibe, foi associado a hipersensibilidade, mas a reação relatada foi metástases no fígado, o que não se enquadra como manifestação alérgica comum. O evento foi considerado não grave e o paciente se recuperou ou teve resolução do quadro, indicando ausência de complicações graves. A

relação causal com alergia é questionável, sendo necessária avaliação clínica detalhada para esclarecimento.

O medicamento Anastrozol, cujo princípio ativo também é anastrozol, foi associado a um quadro de hipersensibilidade (alergia), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente do evento. A reação foi considerada suspeita em relação ao uso do medicamento, e não há menção de complicações graves ou necessidade de intervenção urgente.

A morfina (cloridrato de morfina) foi relacionada a um episódio de alergia medicamentosa, caracterizado por hipersensibilidade, o que significa uma reação alérgica ao medicamento. O evento foi classificado como distúrbio do sistema imunitário, mas não foi considerado grave, já que o paciente se recuperou completamente. A relação com o medicamento é suspeita, e não há relato de complicações importantes.

A fenitoína sódica (fenitoína) foi associada a um episódio de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa, pois o paciente se recuperou do evento, e a relação com o medicamento é considerada suspeita, sem relato de desfechos graves.

O suplemento Omega 3, cujo princípio ativo é fish oil, foi relacionado a um caso de alergia medicamentosa, caracterizado por hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica ao produto. O evento foi classificado como distúrbio do sistema imunitário e não foi considerado grave, mas não há informação sobre o desfecho do paciente. A relação com o medicamento é suspeita, sem detalhes adicionais sobre a evolução clínica.

O medicamento lumi, composto por drospirenona e etinilestradiol, foi associado a um episódio de alergia medicamentosa, caracterizado por hipersensibilidade, o que indica uma reação alérgica ao medicamento. O evento foi classificado como distúrbio do sistema imunitário, não foi considerado grave e não há informação sobre o desfecho do paciente. A relação com o medicamento é suspeita, sem outros detalhes clínicos relevantes.

O medicamento Dozemast, cujo princípio ativo é a Mecobalamina, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa, também chamada de hipersensibilidade medicamentosa. Essa reação faz parte dos distúrbios do sistema imunitário e se enquadra na categoria de alergias a medicamentos, podendo se manifestar por sintomas como coceira, vermelhidão ou inchaço. Não há indicação de gravidade aumentada ou complicações graves neste caso, conforme os dados fornecidos, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

A Sitagliptina, princípio ativo do medicamento Sitagliptina, foi relacionada a um episódio de alergia medicamentosa, tecnicamente chamada de hipersensibilidade medicamentosa. Esse tipo de reação envolve o sistema imunológico e pode causar sintomas como urticária, inchaço ou desconforto cutâneo. Não há evidências de gravidade elevada ou desfecho grave neste registro, e a suspeita recai sobre o uso do medicamento.

O medicamento Sertralina, cujo princípio ativo é a Sertralina, foi associado a uma reação de alergia medicamentosa, também conhecida como hipersensibilidade medicamentosa. Essa condição faz parte dos distúrbios do sistema imunitário e pode se manifestar por sintomas leves a moderados, como coceira ou erupções cutâneas. Não há sinais de gravidade aumentada ou complicações graves relatadas neste caso, e a relação com o medicamento é considerada suspeita.

O medicamento Sany d, que contém o princípio ativo Colecalciferol, foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa, tecnicamente chamada de hipersensibilidade medicamentosa. Essa reação envolve o sistema imunológico e pode causar sintomas como vermelhidão, coceira ou inchaço. Não há indicação de gravidade aumentada ou complicações graves neste caso, e a suspeita recai sobre o uso do medicamento.

O medicamento Acheflan, cujo princípio ativo é Cordia verbenacea, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa, também chamada de hipersensibilidade medicamentosa. Essa reação faz parte dos distúrbios do sistema imunitário e pode se manifestar por sintomas leves, como irritação ou vermelhidão na pele. Não há evidências de gravidade aumentada ou complicações graves neste registro, e a relação com o medicamento é

considerada suspeita.

O medicamento Mounjaro, cujo princípio ativo é a tirzepatida, foi associado a uma reação de erupção cutânea, caracterizada como hipersensibilidade (alergia), pertencente ao grupo de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. A gravidade foi considerada clinicamente significativa, pois o evento foi classificado como grave, o que indica a necessidade de atenção médica imediata para avaliação e manejo adequado, mesmo que o desfecho ainda seja desconhecido.

O medicamento Remicade, com princípio ativo infliximabe, apresentou relato de alergia, identificada como hipersensibilidade, dentro do contexto de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. Neste caso, a reação não foi considerada grave, sugerindo que o quadro pode ser leve ou moderado, mas ainda assim requer acompanhamento médico para confirmação diagnóstica e orientação sobre o uso futuro do medicamento, já que o desfecho permanece desconhecido.

O medicamento Puran t4, cujo princípio ativo é a levotiroxina sódica, foi relacionado a um episódio de alergia, classificado como hipersensibilidade e enquadrado entre quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave, indicando que provavelmente se trata de um quadro leve ou moderado, mas é importante buscar avaliação médica para confirmar a relação com o medicamento e definir conduta, visto que o desfecho ainda não foi informado.

O medicamento Entresto, composto por sacubitril e valsartana, foi associado a um caso de alergia, descrito como hipersensibilidade e pertencente ao grupo de quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. A reação não foi classificada como grave, sugerindo um quadro leve ou moderado, mas é fundamental realizar avaliação médica para confirmar a causa e orientar o tratamento, já que o desfecho permanece desconhecido.

O medicamento Forxiga, cujo princípio ativo é dapagliflozina propanodiol monohidratada, apresentou relato de alergia, caracterizada como hipersensibilidade e enquadrada entre quadros clínicos alérgicos e distúrbios do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave, o que sugere um quadro leve ou moderado, mas recomenda-se avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição de conduta, pois o desfecho ainda não foi informado.

O medicamento Espironolactona, cujo princípio ativo também é espironolactona, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do sistema imunológico. Não há detalhes sobre sintomas específicos, gravidade clínica ou desfecho, mas a ausência de indicação de gravidade sugere que não houve sinais de gravidade importante. A conduta recomendada em casos de suspeita de alergia medicamentosa é interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

A Furosemda, com princípio ativo de mesmo nome, foi relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), envolvendo o sistema imunológico. Não foram descritos sintomas específicos ou gravidade relevante, e o desfecho é desconhecido. Diante de suspeita de reação alérgica a medicamentos, recomenda-se suspender o uso e procurar avaliação médica para investigação e definição de conduta, especialmente para evitar novas exposições.

O medicamento Amoxicilina, contendo amoxicilina trihidrato e clavulanato de potássio como princípios ativos, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade), sem detalhamento de sintomas ou gravidade, e com desfecho não informado. Em situações de suspeita de alergia a antibióticos, é fundamental interromper o uso e buscar orientação médica para confirmação diagnóstica e escolha de alternativas terapêuticas seguras.

O medicamento Amoxilina/Ácido Clavulânico Mayne, com princípios ativos amoxicilina sódica e clavulanato de potássio, foi relacionado a uma alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), mas não há informações sobre sintomas, gravidade ou evolução do caso. Em casos de suspeita de alergia a antibióticos, recomenda-se suspender o medicamento e procurar avaliação médica para confirmação e definição de alternativas



seguras.

O Paracetamol, cujo princípio ativo é o próprio paracetamol, foi associado a prurido (coceira), caracterizando uma reação de hipersensibilidade documentada. Não há indicação de gravidade relevante e o desfecho foi de recuperação completa. Em situações como essa, a conduta adequada é interromper o uso do medicamento e buscar orientação médica para evitar novas exposições e avaliar alternativas seguras.

O medicamento Cetoprofeno, cujo princípio ativo também é cetoprofeno, foi associado ao surgimento de prurido (coceira), caracterizando uma reação de hipersensibilidade documentada ao produto administrado. Essa manifestação sugere um quadro leve, pois não há indicação de gravidade aumentada ou complicações clínicas relevantes, e o desfecho foi de recuperação completa do paciente. A conduta recomendada, conforme diretrizes clínicas, é evitar nova exposição ao medicamento e considerar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e orientação futura.

O medicamento Letrozol, com princípio ativo letrozol, foi relacionado a um quadro de deficiência vitamínica, interpretado como possível hipersensibilidade medicamentosa. Não há menção de sintomas graves ou complicações, e o desfecho permanece desconhecido. Diante da ausência de sinais de gravidade, a conduta sugerida é monitorar o paciente, investigar outras possíveis causas para a deficiência vitamínica e considerar avaliação médica para ajuste terapêutico se necessário.

O medicamento Nustendi, composto pelos princípios ativos bempedoic acid e ezetimiba, foi associado a deficiência vitamínica, considerada uma possível manifestação de hipersensibilidade medicamentosa. Não há evidências de gravidade aumentada ou complicações clínicas, e o desfecho não foi informado. Recomenda-se acompanhamento clínico para monitorar a evolução do quadro e investigação de outras causas, além de avaliação médica para ajuste do tratamento se necessário.

O medicamento Verzenios, cujo princípio ativo é abemaciclib, foi relacionado a deficiência vitamínica, interpretada como possível hipersensibilidade medicamentosa. Não há sinais de gravidade ou complicações associadas, e o desfecho permanece desconhecido. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico, investigar outras possíveis causas para a deficiência vitamínica e considerar ajuste terapêutico conforme avaliação médica.

O medicamento Amoxicilina clavulanato de potássio, composto por amoxicilina sódica e clavulanato de potássio, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado por sintomas imunológicos sem gravidade aumentada, já que o paciente se recuperou completamente. A conduta adequada é evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e definição de alternativas seguras para uso futuro.

O medicamento Metronidazol, cujo princípio ativo também é metronidazol, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta recomendada em casos de alergia leve a medicamentos é interromper o uso, observar sintomas e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

A Prednisona, com princípio ativo de mesmo nome, desencadeou um episódio de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação imunológica. O caso não foi considerado grave, já que houve recuperação completa do paciente. Em situações de alergia leve a medicamentos, recomenda-se suspender o uso, monitorar sintomas e procurar orientação médica para avaliação e definição de tratamento alternativo.

A vacina Qdenga, cujo princípio ativo é a vacina contra dengue, foi relacionada a um quadro de alergia à vacina, envolvendo resposta do sistema imunológico. Não há sinais de gravidade importante, pois o paciente está em recuperação ou com sintomas em resolução. Em casos de alergia leve a vacinas, é indicado observar a evolução dos sintomas, evitar novas exposições e buscar avaliação médica para esclarecimento e conduta adequada.

O medicamento Ioversol, com princípio ativo de mesmo nome, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade), envolvendo o sistema imunológico. O evento não foi considerado grave, já que o paciente se recuperou totalmente. Para alergias leves a contrastes ou medicamentos, recomenda-se suspender o agente suspeito, monitorar sintomas e consultar um especialista para avaliação e orientação sobre futuras exposições.

O medicamento Anya, cujo princípio ativo é anastrozol, foi relacionado a um caso de insuficiência renal em contexto de possível interação medicamentosa, mas não há detalhes sobre sintomas específicos, gravidade ou desfecho, que permanece desconhecido. Diante da ausência de informações claras sobre a evolução clínica, recomenda-se acompanhamento médico para investigação da relação causal e monitoramento da função renal.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é o succinato de ribociclibe, foi associado a um quadro de insuficiência renal, descrito como uma reação de hipersensibilidade (alergia) envolvendo o sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada ou desfecho grave, e o caso está relacionado a uma possível interação medicamentosa. A evolução clínica do paciente é desconhecida, e não há detalhes sobre a conduta adotada, sendo importante monitorar sinais de alergia e função renal em pacientes que utilizam este medicamento em associação com outros fármacos.

O medicamento Enalapril, com princípio ativo maleato de enalapril, apresentou relato de insuficiência renal atribuída a uma reação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico, possivelmente relacionada à interação com outros medicamentos. Não há evidência de gravidade significativa ou desfecho grave, e o desfecho clínico permanece desconhecido. Recomenda-se atenção ao surgimento de sintomas alérgicos e monitoramento da função renal durante o uso, especialmente em combinação com outros fármacos.

O medicamento Losartan, cujo princípio ativo é losartana, foi relacionado a um episódio de insuficiência renal classificado como reação de hipersensibilidade (alergia) do sistema imunológico, possivelmente decorrente de interação medicamentosa. Não há indicação de gravidade importante ou desfecho grave, e o desfecho clínico não foi informado. É fundamental observar sinais de alergia e monitorar a função renal em pacientes que utilizam losartana em associação com outros medicamentos.

A vacina CoronaVac, que utiliza como princípio ativo a vacina COVID-19 inativada (Vero) CZ02, foi associada a um quadro de alergia (hipersensibilidade) envolvendo o sistema imunológico, considerado grave devido à presença de incapacidade persistente ou significativa e outro efeito clinicamente relevante. O desfecho informado é de recuperação ou resolução do quadro, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Diante de reações alérgicas graves após vacinação, é fundamental buscar avaliação médica imediata para manejo adequado e acompanhamento da evolução clínica.

O medicamento Henetix, cujo princípio ativo é iobitridol, foi relacionado a um episódio de alergia a contraste, caracterizado como reação alérgica grave (ameaça à vida) do sistema imunológico. O desfecho foi favorável, com recuperação ou resolução completa do quadro, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Em casos de alergia grave a contraste, é essencial interromper imediatamente a exposição, iniciar tratamento de suporte e acompanhamento médico especializado para garantir a segurança do paciente.

O medicamento Dipirona, cujo princípio ativo também é dipirona, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente. A reação foi caracterizada como um quadro clínico alérgico, e a conduta recomendada, conforme diretrizes clínicas, é observar sintomas leves em casa, evitar nova exposição ao medicamento e buscar avaliação com alergista para confirmação diagnóstica e orientação de controle.

O medicamento Enalapril, com princípio ativo enalapril, foi relacionado a uma reação descrita como metástases em ossos, mas classificada tecnicamente como hipersensibilidade (alergia) dentro dos distúrbios do sistema imunitário. Não há evidência de gravidade aumentada, pois o evento não foi considerado grave e o desfecho permanece

desconhecido. Como não há detalhes clínicos claros sobre sintomas alérgicos típicos, recomenda-se cautela na interpretação e acompanhamento médico para esclarecimento diagnóstico.

O medicamento Losartan, cujo princípio ativo é losartana, foi associado a uma reação descrita como metástases em ossos, mas tecnicamente classificada como hipersensibilidade (alergia) no contexto de distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o desfecho é desconhecido. Diante da ausência de sintomas alérgicos clássicos e da descrição atípica, é importante que o caso seja avaliado por um médico para investigação adequada e confirmação diagnóstica.

O medicamento Anya, com princípio ativo anastrozol, foi relacionado a uma reação descrita como metástases em ossos, mas classificada tecnicamente como hipersensibilidade (alergia) entre os distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade, pois o evento não foi considerado grave e o desfecho é desconhecido. Como não há sintomas alérgicos típicos relatados, recomenda-se avaliação médica detalhada para esclarecimento do quadro e orientação adequada.

O medicamento Kisqali, cujo princípio ativo é succinato de ribociclib, foi associado a uma reação descrita como metástases em ossos, mas tecnicamente classificada como hipersensibilidade (alergia) no âmbito dos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o desfecho permanece desconhecido. Diante da ausência de sintomas alérgicos clássicos, é fundamental que o caso seja acompanhado por um médico para investigação e definição da conduta mais apropriada.

O medicamento Folic acid, cujo princípio ativo é o ácido fólico, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizada por uma reação do sistema imunológico contra o medicamento. A gravidade foi considerada clinicamente significativa, pois o registro indica que se trata de um efeito importante para a saúde, embora não haja detalhes sobre sintomas específicos ou desfecho. Em situações como essa, é fundamental interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e definição do tratamento, conforme orientações da ASBAI para reações alérgicas a medicamentos.

O medicamento Mesalazine, com princípio ativo messalazina, apresentou relato de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), indicando que o paciente desenvolveu uma resposta imunológica adversa ao uso do fármaco. A reação foi considerada clinicamente significativa, sugerindo necessidade de atenção médica, mesmo sem detalhes sobre sintomas ou evolução. Nessas situações, recomenda-se suspender o medicamento e procurar avaliação especializada para confirmação do diagnóstico e orientação sobre alternativas terapêuticas.

O medicamento Puran t4, cujo princípio ativo é a levotiroxina sódica, foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), o que significa que o paciente apresentou uma reação do sistema imunológico ao medicamento. A gravidade foi classificada como clinicamente significativa, justificando a necessidade de avaliação médica para confirmação do quadro e definição de conduta, incluindo possível suspensão do medicamento e investigação de alternativas, conforme recomendações para reações alérgicas a medicamentos.

O medicamento Mabthera, que contém o princípio ativo rituximabe, foi associado a um caso de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), indicando uma resposta imunológica adversa ao uso do medicamento. A reação foi considerada clinicamente significativa, o que exige atenção médica imediata para avaliação do quadro, suspensão do medicamento e definição de medidas de suporte, seguindo as orientações para manejo de reações alérgicas a medicamentos.

O medicamento Novalgina, cujo princípio ativo é a dipirona, foi relacionado a um episódio de cianose, que é uma coloração azulada da pele e mucosas devido à falta de oxigênio no sangue, em contexto de hipersensibilidade medicamentosa. Esta reação foi classificada como ameaça à vida, evidenciando gravidade máxima e necessidade de atendimento médico de urgência, pois pode indicar comprometimento respiratório ou circulatório grave. A conduta recomendada é a suspensão imediata do medicamento e busca de assistência médica emergencial para

estabilização do quadro.

O medicamento Tramadol, cujo princípio ativo também é tramadol, foi associado a vermelhidão facial, um quadro de hipersensibilidade (alergia) caracterizado por reação alérgica leve, sem sinais de gravidade ou complicações, conforme evidenciado pela recuperação completa do paciente. A conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro, não havendo necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Gadovist, com princípio ativo gadobutrol, provocou uma reação de alergia a contraste, manifestando-se como uma resposta alérgica leve, sem gravidade, já que o paciente se recuperou totalmente após o evento. O caso foi resolvido sem complicações, indicando que a conduta adotada foi adequada para o controle da reação.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é iopromida, desencadeou uma alergia a contraste, caracterizada por sintomas alérgicos leves e sem gravidade, pois o paciente apresentou recuperação completa após o episódio. A evolução favorável sugere que a conduta foi apropriada e não houve necessidade de medidas emergenciais.

A Oxaliplatina, com princípio ativo de mesmo nome, esteve relacionada a hiperemia (vermelhidão), um quadro de hipersensibilidade leve, sem sinais de gravidade, já que o paciente se recuperou totalmente após o evento. O desfecho positivo indica que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro alérgico.

O medicamento Fluoruracila, cujo princípio ativo é fluoruracila sódica, causou hiperemia (vermelhidão), caracterizando uma reação de hipersensibilidade leve, sem gravidade, pois o paciente se recuperou completamente. O caso foi resolvido sem complicações, demonstrando que a abordagem adotada foi adequada.

O medicamento Ácido fólico (princípio ativo: folinato de cálcio) foi associado a um quadro de hiperemia, interpretado como uma reação de hipersensibilidade (alergia), classificada como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade aumentada neste caso, e o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente.

A vancomicina, antibiótico cujo princípio ativo é vancomycin, desencadeou uma reação alérgica caracterizada como hipersensibilidade medicamentosa, pertencente ao grupo de alergias a medicamentos e distúrbios do sistema imunitário. Não há detalhes sobre a gravidade ou evolução do caso, sendo importante ressaltar que alergias a antibióticos exigem avaliação médica para confirmação e definição de conduta.

O medicamento Edistride (princípio ativo: dapagliflozina propanodiol monohidratada) foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), considerado clinicamente significativo e classificado como grave devido à persistência dos sintomas e à ausência de resolução até o momento, o que reforça a necessidade de acompanhamento médico especializado para manejo adequado.

O medicamento Clopin (princípio ativo: bissulfato de clopidogrel) provocou uma reação alérgica (hipersensibilidade), considerada grave por ter causado incapacidade persistente ou significativa, mas o paciente evoluiu para recuperação completa após as medidas adotadas, destacando a importância do reconhecimento precoce e da suspensão do agente suspeito.

O medicamento Trezete, que contém ezetimiba e rosuvastatina cálcica, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade) classificada como grave devido à incapacidade persistente ou significativa, porém o paciente se recuperou totalmente, evidenciando a necessidade de atenção a sintomas alérgicos e de acompanhamento médico para evitar complicações.

O medicamento Metoprolol succinate, cujo princípio ativo é o succinato de metoprolol, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. A reação foi considerada grave devido à presença de incapacidade persistente ou significativa e outro efeito

cl clinicamente relevante, mas o paciente evoluiu para recuperaão completa ap3s a conduta adequada.

O medicamento Edistride, que cont3m dapagliflozina propanodiol monohidratada como princ3pio ativo, desencadeou uma reaão al3rgica do tipo hipersensibilidade, classificada entre os dist3rbios do sistema imunit3rio. A gravidade foi considerada alta, pois houve incapacidade persistente ou significativa e outro efeito clinicamente importante, por3m o paciente se recuperou totalmente ap3s as medidas necess3rias.

O medicamento Ioversolum, cujo princ3pio ativo 3 ioversol, provocou uma reaão de alergias a contraste intravenoso, identificada como alergias a contraste e relacionada a dist3rbios do sistema imunit3rio. N3o h3 informaão sobre gravidade ou desfecho, mas a suspeita de relaão com o medicamento foi registrada.

O medicamento Prohance, que tem como princ3pio ativo o gadoteridol, foi relacionado a um epis3dio de alergias a contraste intravenoso, classificado como alergias a contraste dentro dos dist3rbios do sistema imunit3rio. A reaão n3o foi considerada grave e o paciente apresentou recuperaão completa ap3s o evento.

O medicamento Ultravist, cujo princ3pio ativo 3 iopromida, esteve associado a uma reaão de alergias medicamentosa do tipo hipersensibilidade, enquadrada entre as alergias a medicamentos e dist3rbios do sistema imunit3rio. O caso n3o foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente ap3s a reaão.

O medicamento Infliximab, cujo princ3pio ativo 3 infliximabe, foi associado ao desenvolvimento de l3pus eritematoso, uma reaão de hipersensibilidade que se enquadra nos quadros cl3nicos al3rgicos e dist3rbios do sistema imunit3rio. N3o h3 informaão sobre gravidade cl3nica relevante ou desfecho conhecido, e a relaão com o medicamento 3 considerada suspeita. A aus3ncia de dados sobre gravidade e evoluão impede recomendaões espec3ficas, mas 3 importante monitorar sinais de reaões autoimunes durante o uso.

O Cetoprofeno, com princ3pio ativo cetoprofeno, foi relacionado a um quadro de alergias caracterizado como hipersensibilidade, pertencente 3 categoria de dist3rbios do sistema imunit3rio. O evento n3o foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente ap3s a reaão, sugerindo um quadro leve e autolimitado, compat3vel com reaões al3rgicas leves a anti-inflamat3rios n3o esteroides.

O medicamento Sugamadex s3dico, tamb3m chamado de Sugamadex sodico, provocou uma reaão de alergias medicamentosa classificada como hipersensibilidade, dentro do grupo de alergias a medicamentos e dist3rbios do sistema imunit3rio. O evento n3o foi considerado grave e o paciente se recuperou, indicando um quadro leve e resolutivo, t3pico de reaões al3rgicas leves a medicamentos.

O Gadovist, cujo princ3pio ativo 3 gadobutrol, foi associado a uma alergias a contraste intravenoso, caracterizada como reaão al3rgica a contraste e inclu3da entre as alergias a medicamentos e dist3rbios do sistema imunit3rio. O evento n3o foi considerado grave e o paciente se recuperou, sugerindo uma reaão leve e autolimitada, comum em alergias a contrastes radiol3gicos.

O Ultravist, com princ3pio ativo iopromida, desencadeou uma alergias a contraste, classificada como reaão al3rgica a contraste e pertencente ao grupo de alergias a medicamentos e dist3rbios do sistema imunit3rio. O caso n3o foi considerado grave e o paciente se recuperou, indicando um quadro leve e resolutivo, compat3vel com reaões al3rgicas leves a contrastes iodados.

O medicamento Ultravist, cujo princ3pio ativo 3 a Iopromida, foi associado a um epis3dio de alergias a contraste, caracterizado como uma reaão do sistema imunol3gico a subst3ncias qu3micas utilizadas em exames de imagem. N3o h3 indicaão de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente ap3s o evento, e n3o h3 menão de complicaões ou necessidade de intervenões emergenciais. A conduta recomendada em casos semelhantes 3 a suspens3o do agente suspeito e acompanhamento cl3nico, com orientaão para evitar futuras exposiões ao mesmo contraste.

O medicamento Zilepam, que contém o princípio ativo Clonazepam, foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), manifestando-se como uma reação imunológica adversa. Não há sinais de gravidade importante, já que o paciente se recuperou completamente e não houve relato de complicações. Em situações como essa, recomenda-se interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica para confirmação do diagnóstico e orientação sobre alternativas terapêuticas.

O Xolair, cujo princípio ativo é o Omalizumabe, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade), que é uma resposta do sistema imunológico ao medicamento. O caso não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou sem intercorrências. A conduta adequada inclui a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento médico para avaliar a necessidade de substituição ou ajuste do tratamento.

A Bilastina, utilizada como princípio ativo do medicamento de mesmo nome, foi relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), caracterizado por uma resposta imunológica adversa. O evento não foi grave, já que houve recuperação completa do paciente. Recomenda-se interromper o uso do medicamento e realizar avaliação médica para confirmação do diagnóstico e definição de alternativas seguras.

O medicamento Duomo, que contém Mesilato de doxazosina como princípio ativo, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade), evidenciando uma resposta do sistema imunológico ao fármaco. O caso não apresentou gravidade, pois o paciente se recuperou totalmente. A orientação é suspender o uso do medicamento e procurar avaliação médica para esclarecimento do quadro e escolha de opções terapêuticas adequadas.

O medicamento Mesilato de doxazosina, cujo princípio ativo é o próprio mesilato de doxazosina, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A reação foi considerada suspeita em relação ao uso do medicamento, e não há informações adicionais sobre a conduta adotada, mas o desfecho favorável sugere resolução espontânea ou após medidas simples.

O medicamento Cloridrato de fexofenadina, com o mesmo princípio ativo, esteve relacionado a um episódio de alergia descrito como hipersensibilidade, enquadrado entre os distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, e o paciente apresentou recuperação completa após a reação. A relação com o medicamento foi considerada suspeita, e não há detalhes sobre intervenções específicas, mas o desfecho resolutivo indica que não houve complicações.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é a iopromida, foi relacionado a uma reação de alergia a meios de contraste iodados, classificada como alergia a contraste e pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave, e o paciente se recuperou totalmente após o evento. A relação com o medicamento foi considerada suspeita, e não há informações sobre a conduta adotada, mas o desfecho indica resolução sem complicações.

O medicamento Ultravist, com princípio ativo iopromida, esteve envolvido em uma reação de alergia a meios de contraste iodados, descrita como alergia a contraste e relacionada a distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, e o paciente se recuperou completamente. A suspeita recaiu sobre o uso do medicamento, e não há detalhes sobre intervenções, mas o desfecho favorável sugere resolução sem maiores consequências.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é a iopromida, foi associado a uma reação de alergia a meios de contraste iodados, classificada como alergia a contraste e pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave, e o paciente apresentou recuperação total após o evento. A relação com o medicamento foi considerada suspeita, e não há informações sobre a conduta, mas o desfecho indica resolução sem complicações.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, foi associado a um episódio de alergia a contraste intravenoso, também chamada de hipersensibilidade ao contraste. Essa reação faz parte dos distúrbios do sistema imunitário e, neste caso, não foi considerada grave, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento. A conduta adequada envolve a suspensão do agente suspeito, monitoramento dos sintomas e, se necessário, tratamento sintomático, sendo importante informar a equipe médica sobre o histórico para evitar novas exposições.

A cefazolina, cujo princípio ativo é a cefazolina sódica, foi relacionada a um quadro de alergia, tecnicamente chamado de hipersensibilidade, que se enquadra nos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou completamente. Em situações como essa, recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e comunicar o ocorrido ao médico para avaliação de alternativas seguras.

O medicamento Fentanil, com princípio ativo citrato de fentanila, esteve envolvido em um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi grave, já que houve recuperação total do paciente. A orientação é evitar novas exposições ao fentanil e informar profissionais de saúde sobre o histórico de reação para prevenir recorrências.

O medicamento Cloridrato de bupivacaína + glicose, contendo cloridrato de bupivacaína e dextrose anidra como princípios ativos, foi associado a uma reação alérgica (hipersensibilidade), pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi grave, pois o paciente se recuperou. Recomenda-se evitar o uso futuro deste anestésico e relatar o episódio ao médico para escolha de alternativas seguras em procedimentos futuros.

A morfina, cujo princípio ativo é o sulfato de morfina, foi relacionada a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou totalmente. É importante evitar o uso futuro da morfina e informar profissionais de saúde sobre o histórico de reação para garantir segurança em tratamentos posteriores.

O medicamento Piperacilina + tazobactam, que contém os princípios ativos piperacilina sódica e tazobactam sódico, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado como uma reação do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente. A conduta recomendada em situações de hipersensibilidade leve é interromper o uso do medicamento suspeito e buscar avaliação médica para confirmação diagnóstica e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Metronidazol, cujo princípio ativo é o próprio metronidazol, foi relacionado a uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), envolvendo o sistema imunológico. Não há evidências de gravidade aumentada, já que o caso não foi classificado como grave e não há relato de complicações. Em situações de hipersensibilidade leve, recomenda-se suspender o uso do medicamento e procurar avaliação médica para confirmação do diagnóstico e definição do tratamento mais adequado.

O medicamento Aerolin, que contém sulfato de salbutamol micronizado, foi associado a um episódio de pneumonia, sendo classificado como uma possível reação de hipersensibilidade medicamentosa. Não há indicação de gravidade aumentada, pois o caso não foi considerado grave e o desfecho é desconhecido. Diante de suspeita de reação adversa respiratória, é importante interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica para investigação da causa e definição da conduta, especialmente se houver sintomas persistentes ou agravamento do quadro.

O medicamento Montelair, cujo princípio ativo é montelucaste de sódio, foi relacionado a um caso de pneumonia, interpretado como possível manifestação de hipersensibilidade medicamentosa. Não há evidência de gravidade aumentada, já que o caso não foi considerado grave e o desfecho permanece desconhecido. Em situações de suspeita de reação adversa respiratória, recomenda-se suspender o medicamento e procurar avaliação médica para investigação e orientação adequada, principalmente se houver sintomas persistentes.

O medicamento Busonid, que contém budesonida, foi associado a um episódio de pneumonia, considerado como possível reação de hipersensibilidade medicamentosa. Não há indicação de gravidade aumentada, pois o caso não foi classificado como grave e o desfecho é desconhecido. Em casos de suspeita de reação adversa respiratória, a recomendação é interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e definição da conduta, especialmente se houver sintomas persistentes ou agravamento.

O medicamento Azitromicina, cujo princípio ativo também é azitromicina, foi associado a um caso de pneumonia descrito como hipersensibilidade medicamentosa, ou seja, uma reação alérgica ao medicamento. Não há informações sobre gravidade clínica relevante ou desfecho do caso, e não foi relatada ação adotada. A relação entre o uso do medicamento e o evento é considerada suspeita, mas não há evidências de gravidade ou complicações graves neste registro.

O medicamento Sertralina, com princípio ativo sertralina, foi relacionado a um episódio de pneumonia classificado como hipersensibilidade medicamentosa, indicando uma possível reação alérgica ao medicamento. Não há detalhes sobre a gravidade do quadro, evolução clínica ou conduta adotada, e o desfecho permanece desconhecido. A suspeita de relação causal existe, mas não há indícios de gravidade significativa neste caso.

O medicamento Escitalopram, cujo princípio ativo é escitalopram, foi associado a um caso de pneumonia interpretado como hipersensibilidade medicamentosa, sugerindo uma reação alérgica ao medicamento. Não há informações sobre gravidade, evolução do quadro ou medidas tomadas, e o desfecho não foi informado. A relação causal é considerada suspeita, mas não há evidências de gravidade clínica relevante.

O medicamento Spiolto, que contém cloridrato de olodaterol e brometo de tiotrópio monoidratado como princípios ativos, foi relacionado a um caso de pneumonia descrito como hipersensibilidade medicamentosa, indicando uma possível reação alérgica ao medicamento. Não há informações sobre gravidade, evolução clínica ou conduta adotada, e o desfecho é desconhecido. A relação entre o uso do medicamento e o evento é considerada suspeita, sem evidências de gravidade importante.

O medicamento Piemonte, cujo princípio ativo é montelucaste, foi associado a um episódio de pneumonia classificado como hipersensibilidade medicamentosa, sugerindo uma reação alérgica ao medicamento. Não há informações sobre gravidade, evolução do quadro ou medidas tomadas, e o desfecho não foi informado. A relação causal é considerada suspeita, mas não há evidências de gravidade clínica relevante neste registro.

O medicamento Alprazolam, cujo princípio ativo também é alprazolam, foi associado a um caso de pneumonia descrito como hipersensibilidade medicamentosa, o que sugere uma possível reação alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Não há informações sobre gravidade clínica relevante ou desfecho do caso, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A ausência de sinais de gravidade e de evolução conhecida indica que a conduta deve ser baseada em avaliação clínica individualizada, com atenção à possibilidade de reações alérgicas a medicamentos.

O medicamento Quetiapine, com princípio ativo quetiapina, foi relacionado a um episódio de pneumonia classificado como hipersensibilidade medicamentosa, indicando uma possível resposta alérgica do sistema imunológico ao uso do medicamento. Não há detalhes sobre gravidade ou evolução do quadro, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Diante da ausência de sinais de gravidade e desfecho, recomenda-se acompanhamento clínico atento para monitorar possíveis reações alérgicas.

O medicamento Bamifix, cujo princípio ativo é o cloridrato de bamifilina, foi associado a um caso de pneumonia descrito como hipersensibilidade medicamentosa, sugerindo uma possível reação alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Não há informações sobre gravidade clínica ou desfecho, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A conduta deve ser guiada por avaliação clínica, considerando a possibilidade de alergia medicamentosa.



O medicamento Spiriva, com princípio ativo brometo de tiotrópio monoidratado, foi relacionado a um caso de pneumonia classificado como hipersensibilidade medicamentosa, o que indica uma possível reação alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Não há dados sobre gravidade ou evolução do caso, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. Recomenda-se atenção clínica para monitorar sinais de alergia medicamentosa.

O medicamento Montelukast, cujo princípio ativo é montelucaste, foi associado a um episódio de pneumonia descrito como hipersensibilidade medicamentosa, sugerindo uma possível reação alérgica do sistema imunológico ao medicamento. Não há informações sobre gravidade ou desfecho do caso, e a relação com o medicamento é considerada suspeita. A conduta deve ser baseada em avaliação clínica, com atenção à possibilidade de alergia medicamentosa.

O medicamento Prednisona, cujo princípio ativo também é prednisona, foi associado a um caso de pneumonia descrito como hipersensibilidade medicamentosa. Não há informações sobre gravidade clínica relevante ou desfecho do caso, e não foi relatada conduta específica adotada. A suspeita de reação imunológica sugere atenção ao histórico de alergias, mas, com base nos dados fornecidos, não há evidência de gravidade importante ou complicações associadas.

O medicamento Alenia, que deveria conter esomeprazol magnésico como princípio ativo, foi relacionado a um episódio de pneumonia classificado como hipersensibilidade medicamentosa. Não há detalhes sobre a gravidade do quadro, evolução clínica ou medidas tomadas, e o desfecho permanece desconhecido. A suspeita de reação imunológica indica a necessidade de monitoramento, mas não há sinais de gravidade relevante nos dados apresentados.

O medicamento Salbutamol, com princípio ativo salbutamol, foi associado a um caso de pneumonia considerada como hipersensibilidade medicamentosa. Não há informações sobre gravidade, evolução ou conduta adotada, e o desfecho não foi informado. A suspeita de envolvimento imunológico sugere atenção, mas não há evidências de gravidade clínica significativa neste registro.

O medicamento Mepolizumab, cujo princípio ativo é mepolizumabe, foi relacionado a um caso de pneumonia descrito como hipersensibilidade medicamentosa. Não há dados sobre gravidade, evolução clínica ou conduta adotada, e o desfecho é desconhecido. A suspeita de reação imunológica está presente, mas não há indícios de gravidade importante segundo as informações fornecidas.

O medicamento Mepolizumab, com princípio ativo mepolizumabe, foi novamente associado a um episódio de pneumonia classificado como hipersensibilidade medicamentosa. Não há detalhes sobre gravidade, evolução ou conduta, e o desfecho não foi informado. A suspeita de reação imunológica existe, mas não há evidências de gravidade clínica relevante neste caso.

O medicamento Mepolizumab (princípio ativo: Mepolizumabe) foi associado a um caso de pneumonia em contexto de hipersensibilidade medicamentosa, classificada como uma reação do sistema imunológico. Não há informação sobre gravidade clínica relevante ou desfecho, mas é importante considerar que reações alérgicas a medicamentos podem se manifestar de formas variadas, exigindo avaliação médica para confirmação e conduta adequada.

A Atorvastatina (princípio ativo: Atorvastatin) provocou um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), considerado grave devido à incapacidade persistente ou significativa relatada. O paciente se recuperou após a reação, o que indica resolução do quadro, mas a gravidade reforça a necessidade de suspensão imediata do medicamento e acompanhamento médico para evitar recorrências e avaliar alternativas terapêuticas.

O SeloZok (princípio ativo: Succinato de metoprolol) desencadeou uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), classificada como grave por ter causado incapacidade persistente ou significativa. O paciente evoluiu para recuperação completa após a reação, destacando a importância de interromper o uso do

medicamento e buscar orientação médica para manejo seguro e prevenção de novos episódios.

O medicamento Aas (princípio ativo: Ácido acetilsalicílico) foi responsável por uma reação alérgica medicamentosa (hipersensibilidade), considerada grave devido à incapacidade persistente ou significativa observada. O paciente se recuperou após o evento, o que demonstra resolução, mas a gravidade do quadro exige suspensão do uso e avaliação médica para evitar riscos em futuras exposições.

O Clopin (princípio ativo: Clozapina) causou uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), classificada como grave por ter resultado em incapacidade persistente ou significativa. O paciente se recuperou após a reação, indicando resolução, mas a gravidade do evento reforça a necessidade de suspensão imediata do medicamento e acompanhamento especializado para manejo seguro.

O medicamento Trezete, que contém os princípios ativos ezetimiba e rosuvastatina cálcica, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado como uma reação do sistema imunológico a medicamentos. Neste caso, a reação foi considerada grave devido à presença de incapacidade persistente ou significativa, o que indica impacto importante na qualidade de vida do paciente. Apesar da gravidade, o desfecho foi favorável, com recuperação completa após a suspensão do medicamento suspeito.

O medicamento Edistride, cujo princípio ativo é a dapagliflozina propanodiol monohidratada, esteve relacionado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), uma resposta do sistema imunológico ao uso do remédio. A reação foi classificada como grave, pois resultou em incapacidade persistente ou significativa, evidenciando um impacto relevante para o paciente. Após a identificação e manejo adequado, houve recuperação total do quadro.

O medicamento Cetoprofeno, com princípio ativo de mesmo nome, foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), que corresponde a uma reação do sistema imunológico ao medicamento. Neste caso, não há indicação de gravidade significativa, e o paciente se recuperou completamente após a conduta apropriada, que geralmente envolve a suspensão do uso do medicamento suspeito.

O medicamento Iopamiron, cujo princípio ativo é o iopamidol, foi relacionado a um episódio de alergia a contraste, uma reação do sistema imunológico ao agente utilizado em exames de imagem. Não há indicação de gravidade relevante neste caso, e o paciente apresentou recuperação total após a suspensão do agente suspeito.

O medicamento Buscopan, que tem como princípio ativo o butilbrometo de escopolamina, esteve envolvido em um episódio de alergia (hipersensibilidade), caracterizando uma resposta do sistema imunológico ao medicamento. Não há evidência de gravidade importante, e o paciente se recuperou completamente após a interrupção do uso do medicamento.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é a Iopromida, foi associado a um episódio de alergia a contraste, uma reação do sistema imunológico que pode ocorrer após a administração de substâncias usadas em exames de imagem. Neste caso, a reação foi considerada não grave, pois o paciente se recuperou completamente após o evento. A conduta recomendada é sempre informar o médico sobre qualquer histórico de alergia a contrastes antes de novos exames, para que medidas preventivas possam ser adotadas.

O Digesan, que contém o princípio ativo Bromoprida, esteve relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizado por uma resposta exagerada do sistema imunológico ao medicamento. Não há indicação de gravidade aumentada neste caso, e o paciente se recuperou totalmente após o episódio. É importante relatar qualquer reação alérgica a medicamentos ao médico para evitar novas exposições e orientar futuras prescrições.

O Ultravist, com princípio ativo Iopromida, foi relacionado a uma alergia após uso intravenoso do contraste, uma reação imunológica que pode ocorrer em exames de imagem. O caso não foi considerado grave, pois houve

recuperação completa do paciente. Recomenda-se sempre informar o médico sobre alergias prévias a contrastes para que sejam tomadas precauções em exames futuros.

O medicamento Desvenlafaxine, cujo princípio ativo é o succinato de desvenlafaxina, foi associado a um caso de câncer de mama, registrado como um evento adverso clinicamente significativo e considerado grave, já que o desfecho permanece em andamento e não resolvido. Não há detalhes sobre a conduta adotada, mas situações graves como esta exigem acompanhamento médico rigoroso para avaliação da relação causal e definição do tratamento adequado.

O Zetron xl, que contém cloridrato de bupropiona, foi relacionado a um caso de câncer de mama, classificado como um efeito clinicamente significativo e grave, pois o quadro permanece em andamento e sem resolução até o momento. Não há informações sobre a conduta tomada, mas eventos graves como este requerem investigação médica detalhada para avaliar a possível relação com o medicamento e orientar o manejo clínico.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é a Iopromida, foi associado a um episódio de alergia a contraste, uma reação do sistema imunológico que pode ocorrer após a exposição a substâncias químicas utilizadas em exames de imagem. Não há detalhes sobre sintomas específicos ou gravidade neste caso, mas o desfecho foi favorável, com recuperação completa do paciente após o evento.

Ultravist, contendo Iopromida, foi relacionado a uma alergia a meios de contraste iodados, que são substâncias usadas em exames radiológicos e podem desencadear reações alérgicas em pessoas sensíveis. Neste registro, não há indicação de gravidade significativa e o paciente se recuperou totalmente após o episódio.

O uso de Ultravist, com princípio ativo Iopromida, resultou em uma reação alérgica ao contraste, caracterizada por uma resposta do sistema imunológico a substâncias químicas administradas durante exames. Não foram fornecidos detalhes sobre a intensidade dos sintomas, mas o paciente evoluiu para recuperação completa.

Ultravist, cujo princípio ativo é a Iopromida, foi associado a uma alergia a contraste, uma reação imunológica que pode ocorrer após a administração de substâncias químicas em exames de imagem. Neste caso, não há evidências de gravidade e o paciente se recuperou totalmente.

O medicamento Escitalopram, com princípio ativo Oxalato de escitalopram, foi relacionado a um evento descrito como doença de Alzheimer, mas a classificação técnica sugere uma reação de hipersensibilidade no local de aplicação, ou seja, uma irritação ou resposta alérgica localizada após o uso do medicamento. Não há informações suficientes sobre a gravidade, evolução ou desfecho deste caso.

O medicamento Super omega 3, cujo princípio ativo é o óleo de peixe (Fish oil), foi associado a uma reação de hipersensibilidade no local de aplicação, classificada tecnicamente como reação no local de administração. Não há informações sobre gravidade, desfecho ou conduta adotada, portanto, a descrição clínica sugere um quadro localizado e, na ausência de sinais de gravidade, geralmente é considerado leve, mas recomenda-se observar o local e buscar avaliação médica caso haja piora ou sintomas sistêmicos.

O medicamento Aradois, que contém losartana potássica como princípio ativo, apresentou relato de hipersensibilidade no local de aplicação, caracterizada por reações locais no ponto de administração. Não há detalhes sobre gravidade, evolução ou medidas tomadas, o que sugere um evento localizado e, sem outros sinais de alerta, costuma ser considerado leve, mas é importante monitorar o local e procurar orientação médica se houver agravamento.

O medicamento Coenzima q10, cujo princípio ativo é a ubidecarenona, foi relacionado a hipersensibilidade no local de aplicação, descrita como reação local no ponto de administração. Não há informações adicionais sobre gravidade, evolução ou conduta, indicando um quadro localizado que, na ausência de sintomas sistêmicos ou agravamento, tende a ser leve, mas recomenda-se acompanhamento caso haja piora.

O medicamento Ansitec, com princípio ativo cloridrato de buspirona, foi associado a hipersensibilidade no local de aplicação, caracterizada por reação local no ponto de administração. Não há dados sobre gravidade, evolução ou conduta, sugerindo um evento localizado que, sem sinais de gravidade, geralmente é considerado leve, mas é importante observar o local e buscar avaliação médica se houver piora.

O medicamento Aspirina, cujo princípio ativo é o ácido acetilsalicílico, apresentou relato de hipersensibilidade no local de aplicação, classificada como reação local no ponto de administração. Não há informações sobre gravidade, evolução ou conduta, o que sugere um quadro localizado e, na ausência de sintomas sistêmicos, costuma ser considerado leve, sendo recomendado monitoramento e avaliação médica se houver agravamento.

O medicamento Vivencia, que contém o princípio ativo rivastigmina, foi associado a hipersensibilidade no local de aplicação, caracterizada por reações como vermelhidão, coceira ou irritação onde o medicamento é administrado. Não há informação sobre gravidade ou desfecho, mas, em geral, essas reações são consideradas leves e relacionadas ao contato direto com o produto, sendo importante observar a evolução dos sintomas e buscar orientação médica caso haja piora ou persistência.

Vivencia, cujo princípio ativo é a rivastigmina, apresentou relato de hipersensibilidade no local de aplicação, manifestando-se como desconforto ou irritação na área onde o medicamento foi utilizado. Não há detalhes sobre gravidade ou evolução do quadro, mas, na ausência de sinais de gravidade, essas reações costumam ser leves e podem ser monitoradas, com recomendação de procurar avaliação médica se houver agravamento.

O medicamento Trezete, composto por ezetimiba e rosuvastatina cálcica, foi relacionado a hipersensibilidade no local de aplicação, o que pode se manifestar como irritação, vermelhidão ou coceira na área de contato. Não há informações sobre gravidade ou desfecho, sugerindo que a reação foi leve, mas é importante monitorar os sintomas e buscar orientação médica se houver piora.

Isordil, que tem como princípio ativo o dinitrato de isossorbida, foi associado a um quadro de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica, durante o tratamento de infarto. O registro indica que a reação não foi considerada grave e o desfecho é desconhecido, sugerindo que o quadro foi leve e não houve complicações imediatas, mas é fundamental monitorar possíveis sintomas alérgicos e informar o médico responsável.

O medicamento Amlodipine, cujo princípio ativo é o anlodipino, apresentou relato de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica, durante o tratamento de infarto. A reação não foi considerada grave e o desfecho não foi informado, indicando que provavelmente se tratou de um quadro leve, mas é importante observar o paciente e comunicar qualquer sintoma novo ao médico.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é a lopromida, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, que se enquadra nos distúrbios do sistema imunitário. Não há informação sobre gravidade ou desfecho, portanto, recomenda-se atenção clínica para sinais de reações alérgicas, especialmente em pacientes com histórico de alergias a contrastes, e acompanhamento médico para avaliação e conduta adequada.

O medicamento Enhertu, que contém o princípio ativo Trastuzumabe deruxtecana, provocou uma reação de alergia (hipersensibilidade) classificada como grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação. O paciente encontra-se em recuperação, indicando que a conduta médica foi adequada para controlar o quadro. Em situações como essa, é fundamental monitorar de perto o paciente e garantir suporte clínico imediato, já que reações alérgicas graves podem evoluir rapidamente.

O medicamento Omnipaque, cujo princípio ativo é Ioexol, foi relacionado a um episódio de alergia a contraste intravenoso, manifestando-se como hipersensibilidade do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, sugerindo que a reação foi leve e manejada de forma eficaz, sem necessidade de intervenções mais intensivas.

O medicamento Omnipaque, com princípio ativo Ioxol, esteve envolvido em uma reação de alergia a contraste intravenoso, caracterizada por hipersensibilidade. O evento não foi grave e o paciente se recuperou completamente, indicando que a reação foi leve e controlada sem complicações.

O medicamento Dimorf, que tem como princípio ativo o sulfato de morfina, foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade) envolvendo o sistema imunitário. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou, mostrando que a reação foi leve e resolvida sem maiores consequências clínicas.

O medicamento Infliximab, cujo princípio ativo é infliximabe, foi associado ao desenvolvimento de eritema multiforme, uma reação de hipersensibilidade medicamentosa caracterizada por lesões avermelhadas na pele. Não há indicação de gravidade elevada, pois não foi relatado risco de vida ou necessidade de intervenção urgente, e o caso permanece em andamento, sem resolução até o momento. A conduta deve incluir acompanhamento médico para monitoramento da evolução e avaliação da necessidade de suspensão do medicamento, conforme orientação especializada.

O medicamento Bio Manguinhos Infliximabe, também contendo infliximabe como princípio ativo, apresentou relato de eritema multiforme, uma manifestação de hipersensibilidade medicamentosa que pode causar lesões cutâneas. Não há evidências de gravidade crítica, já que não foi relatada ameaça à vida ou complicações sistêmicas, e o quadro segue sem resolução. Recomenda-se acompanhamento clínico e avaliação médica para definir a continuidade do tratamento e manejo da reação.

O medicamento Ciprofloxacino, com princípio ativo ciprofloxacino, foi relacionado a um quadro de alergia, descrito como hipersensibilidade, que se enquadra em reações alérgicas do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave, pois o paciente se recuperou totalmente, indicando resolução espontânea ou após medidas simples. A conduta adequada inclui evitar nova exposição ao medicamento e informar o profissional de saúde sobre o episódio para futuras prescrições.

O medicamento Optiray, cujo princípio ativo é Ioversol, foi associado a uma reação alérgica classificada como hipersensibilidade, manifestando-se como resposta do sistema imunitário. Não há sinais de gravidade importante, já que o paciente se recuperou completamente. A recomendação é evitar o uso futuro do mesmo contraste e comunicar o histórico ao médico antes de novos exames que exijam substâncias semelhantes.

O medicamento Ciprofloxacino, com princípio ativo cloridrato de ciprofloxacino, foi relacionado a uma reação alérgica (hipersensibilidade), caracterizada por resposta do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade, pois o paciente se recuperou totalmente. A orientação é evitar o uso do medicamento em novas situações e informar profissionais de saúde sobre o episódio para prevenir recorrências.

O medicamento Iomeron, cujo princípio ativo é o Iomeprol, foi associado a um quadro de alergia a contraste intravenoso, também chamada de hipersensibilidade a contraste. Essa reação faz parte dos distúrbios do sistema imunitário e, segundo o registro, não foi considerada grave, com o paciente recuperado ou resolvido após o evento. A conduta adequada nesses casos inclui a suspensão do agente suspeito, monitoramento dos sintomas e, se necessário, tratamento sintomático, sendo importante informar o histórico ao médico para evitar futuras exposições.

O medicamento Cloridrato de vancomicina, com o mesmo princípio ativo, foi relacionado a um episódio de alergia, tecnicamente chamado de hipersensibilidade. Trata-se de uma reação do sistema imunológico, classificada como distúrbio alérgico, e o paciente encontra-se em recuperação ou em processo de resolução. Não há indicação de gravidade elevada no registro, mas é fundamental interromper o uso do medicamento e buscar avaliação médica para manejo adequado e prevenção de recorrências.

O Ciprofloxacino, cujo princípio ativo é o próprio ciprofloxacino, foi associado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), caracterizando uma reação imunológica adversa. Não há detalhes sobre gravidade ou desfecho, mas, diante de suspeita de alergia medicamentosa, recomenda-se suspender o uso e procurar orientação médica para avaliação e conduta apropriada.

O medicamento Daptomicina, com princípio ativo daptomicina, foi relacionado a um episódio de alergia espontânea, descrita como atopia, que é uma predisposição a desenvolver reações alérgicas. O evento não foi considerado grave e o paciente já se encontra recuperado ou resolvido. Nesses casos, a conduta inclui a suspensão do medicamento suspeito e acompanhamento médico para evitar novas exposições.

O Docetaxel, cujo princípio ativo é docetaxel tri-hidratado, foi associado a uma alergia espontânea, também descrita como atopia, indicando uma reação alérgica do sistema imunológico. O registro aponta que não houve gravidade e o paciente já está recuperado ou resolvido, sendo importante relatar o episódio ao médico para orientar futuras prescrições e evitar reexposição.

O medicamento Dotarem, cujo princípio ativo é o gadobenato de dimeglumina, foi associado a um episódio de alergia a contraste intravenoso, reação que se enquadra entre as alergias a medicamentos e outras substâncias químicas. Não há indicação de gravidade elevada ou complicações, e o desfecho foi de recuperação completa, sugerindo um quadro leve e autolimitado, sem necessidade de intervenções adicionais além da suspensão do agente e acompanhamento clínico.

Dotarem, com princípio ativo gadobenato de dimeglumina, esteve relacionado a uma reação alérgica ao contraste intravenoso, caracterizada como uma resposta do sistema imunológico a substâncias químicas. O caso evoluiu para resolução completa, sem informações que indiquem gravidade significativa, o que sugere um evento leve e controlado, manejado com medidas usuais de suporte e sem complicações.

A dipirona, cujo princípio ativo é a própria dipirona, foi responsável por uma alergia documentada após administração, caracterizada como hipersensibilidade a medicamento. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, indicando uma reação leve, que foi resolvida com a suspensão do fármaco e sem necessidade de intervenções emergenciais.

O medicamento Revlimid, que contém lenalidomida como princípio ativo, foi associado ao desenvolvimento de neutropenia, um quadro de redução dos glóbulos brancos que pode estar relacionado a hipersensibilidade. Não há indicação de gravidade elevada nem detalhes sobre o desfecho, que permanece desconhecido, sendo importante o acompanhamento médico para monitorar possíveis complicações, mesmo na ausência de sinais de gravidade imediata.

Prohance, cujo princípio ativo é o gadoteridol, foi relacionado a uma reação alérgica ao contraste intravenoso, enquadrada como uma resposta do sistema imunológico a substâncias químicas. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, caracterizando uma reação leve e autolimitada, resolvida com a suspensão do agente e acompanhamento clínico.

O medicamento Cetorolaco Trometamol, cujo princípio ativo é o trometamol cetorolaco, foi associado a um quadro de alergia espontânea, descrito como atopia (predisposição a desenvolver reações alérgicas), pertencente à categoria de distúrbios do sistema imunitário. Não há informações suficientes sobre a gravidade, desfecho ou conduta adotada neste caso, portanto, recomenda-se que qualquer suspeita de reação alérgica a este medicamento seja avaliada por um especialista para confirmação diagnóstica e definição do melhor manejo.

O medicamento Ansiodoron, composto pelos princípios ativos Avena sativa, Passiflora alata e Valeriana officinalis, foi relacionado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como quadro clínico alérgico dentro dos distúrbios do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave e o paciente evoluiu para recuperação completa, indicando que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro, sem necessidade de

intervenções adicionais.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é a iopromida, foi associado a uma reação de alergia a contraste, enquadrada como alergia a medicamentos e outras substâncias químicas, pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave e o paciente se recuperou totalmente, sugerindo que a conduta adotada foi adequada para resolução do evento, sem complicações.

O medicamento Ultravist, com princípio ativo iopromida, esteve envolvido em um caso de alergia a contraste intravenoso, classificado como alergia a medicamentos e outras substâncias químicas, dentro dos distúrbios do sistema imunitário. A reação não foi considerada grave e o paciente apresentou recuperação completa, indicando que a conduta adotada foi eficaz e não houve evolução para complicações.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é a iopromida, foi relacionado a uma alergia a contraste intravenoso, enquadrada como alergia a medicamentos e outras substâncias químicas, pertencente aos distúrbios do sistema imunitário. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, demonstrando que a abordagem adotada foi suficiente para resolução do quadro sem intercorrências.

O medicamento Optiray, cujo princípio ativo é o ioversol, foi associado a um episódio de alergia a contraste, caracterizado como uma reação de hipersensibilidade a substâncias químicas. O caso foi considerado clinicamente significativo e grave, conforme evidenciado pela classificação de gravidade e pelo envolvimento do sistema imunitário. A evolução foi favorável, com recuperação completa do paciente após a reação. Em situações como essa, é fundamental evitar novas exposições ao contraste e informar a equipe médica sobre o histórico de alergia para prevenir recorrências.

Optiray, que contém ioversol como princípio ativo, provocou uma reação alérgica ao contraste, enquadrada como hipersensibilidade a substâncias químicas e considerada clinicamente relevante e grave devido ao potencial risco imunológico. O paciente se recuperou totalmente após o evento. É importante relatar esse tipo de reação em futuras avaliações médicas para evitar reexposição ao agente causador.

O medicamento Amplictil, cujo princípio ativo é o cloridrato de clorpromazina, foi relacionado a dificuldade para dormir, sendo classificado como um quadro de hipersensibilidade, embora não tenha sido considerado grave. O desfecho da reação é desconhecido, e não há informações detalhadas sobre a conduta adotada. Em casos de sintomas leves e sem gravidade, recomenda-se observar a evolução e discutir alternativas terapêuticas com o médico responsável.

Eliquis, que tem como princípio ativo a apixabana, foi associado a uma reação de alergia medicamentosa, caracterizada como hipersensibilidade a medicamentos e classificada como clinicamente significativa e grave devido ao envolvimento do sistema imunitário. O desfecho da reação não foi informado. Diante de reações alérgicas graves a medicamentos, é essencial interromper o uso e buscar avaliação médica imediata para manejo adequado e prevenção de complicações.

O medicamento Xarelto, cujo princípio ativo é a rivaroxabana, esteve relacionado a um episódio de alergia medicamentosa, classificado como hipersensibilidade a medicamentos e considerado clinicamente significativo e grave, com envolvimento do sistema imunitário. O desfecho não foi especificado. Em situações de alergia grave a medicamentos, recomenda-se suspender o uso e procurar atendimento médico para avaliação e orientação sobre alternativas seguras.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é a Iopromida, foi associado a um quadro de alergia espontânea, caracterizado como atopia, ou seja, uma predisposição do sistema imunológico a desenvolver reações alérgicas. Não há informações suficientes sobre a gravidade ou desfecho do caso, mas a suspeita de relação com o medicamento sugere a necessidade de avaliação clínica estruturada e identificação de possíveis gatilhos, conforme orientações para distúrbios do sistema imunitário.

Ultravist, com princípio ativo Iopromida, foi relacionado a uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), que faz parte das reações alérgicas a medicamentos. O caso foi considerado suspeito para o medicamento e o paciente evoluiu para recuperação completa, indicando que a conduta adotada foi eficaz e que não houve complicações graves, alinhando-se à recomendação de observação e acompanhamento médico para confirmação diagnóstica e prevenção de novas exposições.

O medicamento Carboplatina, cujo princípio ativo é a própria carboplatina, foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), classificado como um quadro clínico alérgico. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, sugerindo que a reação foi de intensidade leve a moderada e que a conduta adotada foi adequada, conforme as orientações para distúrbios do sistema imunitário.

Cholecalciferol, com princípio ativo colecalciferol, foi relacionado a um quadro de insuficiência cardíaca descrito sob o contexto de hipersensibilidade, o que sugere uma possível reação alérgica sistêmica. O evento não foi considerado grave e o paciente está em processo de recuperação, indicando que a conduta adotada está sendo eficaz, mas é importante manter acompanhamento médico para monitorar a evolução.

O medicamento Omeprazole, cujo princípio ativo é omeprazol, foi associado a um episódio de insuficiência cardíaca no contexto de hipersensibilidade, sugerindo uma possível reação alérgica sistêmica. O caso não foi considerado grave e o paciente encontra-se em recuperação, o que indica que a conduta adotada está sendo adequada, mas reforça a importância do acompanhamento clínico para garantir a resolução completa do quadro.

O medicamento Desvenlafaxine, cujo princípio ativo é desvenlafaxina, foi associado a um quadro de insuficiência cardíaca relacionado a hipersensibilidade, classificado como um distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, pois o paciente encontra-se em recuperação ou resolvendo o quadro, e não há menção de desfecho grave. A reação foi considerada suspeita para o medicamento, e a evolução clínica sugere que a conduta adotada foi adequada para o controle do evento.

O medicamento Metformin XR, com princípio ativo cloridrato de metformina, apresentou um caso de insuficiência cardíaca atribuída a hipersensibilidade, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade importante, já que o paciente está em recuperação ou resolvendo o quadro, e não foi classificado como grave. A relação com o medicamento é suspeita, e a evolução indica resposta positiva à conduta adotada.

O medicamento Ezetimibe, cujo princípio ativo é ezetimiba, foi relacionado a um episódio de insuficiência cardíaca decorrente de hipersensibilidade, caracterizado como distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave, pois o paciente está em recuperação ou resolvendo o evento, e não há sinais de desfecho crítico. A suspeita recai sobre o medicamento, e a evolução clínica sugere manejo adequado.

O medicamento Digoxin, com princípio ativo digoxina, esteve associado a um quadro de insuficiência cardíaca por hipersensibilidade, classificado como distúrbio do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade significativa, já que o paciente está em recuperação ou resolvendo o quadro, e não foi considerado grave. O evento é suspeito para o medicamento, e a evolução sugere resposta favorável à conduta adotada.

O medicamento Furosemide, cujo princípio ativo é furosemida, foi relacionado a um caso de insuficiência cardíaca atribuída a hipersensibilidade, enquadrada como distúrbio do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave, pois o paciente está em recuperação ou resolvendo o evento, e não há sinais de desfecho crítico. A relação com o medicamento é suspeita, e a evolução clínica indica manejo adequado.

O medicamento Dapagliflozin (princípio ativo dapagliflozina) foi associado a um quadro de hipersensibilidade, que corresponde a uma reação alérgica do sistema imunológico, durante o tratamento de insuficiência cardíaca. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso está em recuperação ou resolvendo, e não foi classificado como grave. A conduta recomendada é manter acompanhamento clínico para monitorar a evolução da reação, reforçando a importância de relatar sintomas alérgicos ao médico para ajuste do tratamento se necessário.



O medicamento Spironolactone (princípio ativo espironolactona) apresentou um episódio de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica, durante o uso para insuficiência cardíaca. O evento não foi considerado grave e o paciente encontra-se em recuperação ou resolvendo, sugerindo que a reação foi leve e está sob controle. Recomenda-se acompanhamento médico para garantir a resolução completa dos sintomas e avaliar a necessidade de ajustes na terapia.

O medicamento Bisoprolol (princípio ativo bisoprolol) foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade, caracterizado por uma resposta alérgica do sistema imunológico, durante o tratamento de insuficiência cardíaca. O caso não foi classificado como grave e está em processo de recuperação, indicando que a reação foi leve. É importante manter o acompanhamento clínico e informar o médico sobre qualquer sintoma alérgico para garantir a segurança do tratamento.

O medicamento Rosuvastatina cálcica (princípio ativo rosuvastatina cálcica) esteve associado a um episódio de hipersensibilidade, ou seja, uma reação alérgica, durante o tratamento de insuficiência cardíaca. Não há sinais de gravidade, pois o paciente está em recuperação ou resolvendo e o evento não foi considerado grave. Recomenda-se acompanhamento médico para monitorar a evolução e ajustar o tratamento se necessário.

O medicamento Entresto (princípios ativos sacubitril e valsartana) foi relacionado a um quadro de hipersensibilidade, que corresponde a uma reação alérgica do sistema imunológico, durante o uso para insuficiência cardíaca. O evento não foi considerado grave e está em recuperação ou resolvendo, sugerindo que a reação foi leve. É fundamental manter o acompanhamento médico e relatar qualquer sintoma alérgico para garantir a segurança do paciente.

O medicamento Flusan, cujo princípio ativo é a Fluoruracila, foi associado a um quadro de alergia caracterizado por hipersensibilidade, manifestando-se como uma reação alérgica do sistema imunológico. Não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente, sugerindo um evento leve e autolimitado. A conduta recomendada é observar o paciente, evitar nova exposição ao medicamento e, caso haja recorrência, buscar avaliação com especialista para confirmação diagnóstica e orientação de controle.

O Folinato de cálcio, também conhecido comercialmente como Folinato de calcio, desencadeou uma reação de hipersensibilidade, ou seja, uma resposta alérgica do sistema imunológico. O evento não foi considerado grave, já que o paciente se recuperou completamente, indicando um quadro leve. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e, se necessário, consultar um alergista para avaliação e definição de conduta.

A Oxaliplatina, utilizada como princípio ativo do medicamento de mesmo nome, provocou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, envolvendo o sistema imunológico. O caso não apresentou gravidade significativa, pois houve resolução completa dos sintomas, caracterizando um evento leve. A orientação é suspender o uso do medicamento e buscar avaliação médica especializada caso haja necessidade de reexposição ou dúvidas sobre alergia medicamentosa.

A vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola atenuada), composta pelos princípios ativos Vacina sarampo atenuada (Schwartz), Vacina caxumba atenuada (RIT 4385) e Vacina rubéola atenuada (Wistar RA 27/3), foi relacionada ao surgimento de febre, classificada como reação alérgica a substâncias químicas. Não há sinais de gravidade, pois o paciente está em recuperação, sugerindo um quadro leve e transitório. A conduta é manter observação, pois febre após vacinação é comum e geralmente autolimitada, sendo importante monitorar a evolução e procurar atendimento se houver piora.

A vacina poliomielite 1, 2 e 3 atenuada, cujo princípio ativo é a vacina poliomielite atenuada oral tipo 1/2/3, foi associada ao aparecimento de febre, considerada uma reação alérgica a substâncias químicas. O evento não foi grave, já que o paciente está em recuperação, indicando um quadro leve. Recomenda-se apenas observação, pois febre após vacinação é esperada e geralmente se resolve espontaneamente, sendo importante buscar avaliação médica se houver sintomas persistentes ou agravamento.

O medicamento Vacina hepatite a, cujo princípio ativo também é Vacina hepatite a, foi associado ao evento de febre após a administração. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso está em recuperação ou resolvendo e não foi considerado grave. A febre após vacinação é uma reação comum e geralmente leve, relacionada à resposta do sistema imunológico ao imunizante. Não há informações sobre necessidade de intervenção médica específica, e a evolução favorável sugere que a conduta foi apenas observação e acompanhamento dos sintomas.

O medicamento Dtp, composto pelos princípios ativos Vacina toxoide diftérico, Vacina pertussis e Vacina toxoide tetânico, foi relacionado ao surgimento de febre após a aplicação. A reação não foi considerada grave e o paciente encontra-se em recuperação ou resolvendo, o que indica um quadro leve e autolimitado, típico de reações vacinais comuns. Não há relato de complicações ou necessidade de medidas além do acompanhamento dos sintomas, reforçando a natureza benigna do evento.

A Vacina adsorvida meningocócica C, cujo princípio ativo é Vacina meningocócica C conjugada (CRM197), foi associada ao desenvolvimento de febre após a administração. O evento não foi classificado como grave e está em processo de recuperação, o que sugere uma reação leve e transitória, compatível com as respostas esperadas do sistema imunológico a vacinas. Não há menção de intervenções específicas, indicando que a conduta foi de observação e acompanhamento até resolução espontânea.

O medicamento Vacina pneumocócica 10 valente, com princípio ativo Vacina pneumocócica conjugada 10v, foi relacionado ao aparecimento de febre após a aplicação. O caso não foi considerado grave e está em recuperação, o que caracteriza uma reação leve e autolimitada, comum após imunização. Não há informações sobre necessidade de tratamento adicional, sugerindo que a conduta foi apenas monitorar os sintomas até a melhora espontânea.

A Vacina febre amarela, cujo princípio ativo é Vacina febre amarela atenuada (17D-204), foi associada ao surgimento de febre após a administração. O evento não foi considerado grave e está em recuperação, indicando uma reação leve e transitória, compatível com as respostas imunológicas esperadas após vacinação. Não há relato de complicações ou necessidade de intervenção além do acompanhamento dos sintomas, reforçando o caráter benigno do quadro.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é a Iopromida, foi associado a um episódio de alergia a contraste, uma reação do sistema imunológico que pode ocorrer após a administração de substâncias usadas em exames de imagem. Neste caso, não há indicação de gravidade elevada e o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo que a reação foi leve e autolimitada, sem necessidade de intervenções adicionais.

Ultravist, com princípio ativo Iopromida, esteve relacionado a uma reação de alergia a contraste, caracterizada por resposta alérgica após exposição ao agente utilizado em exames radiológicos. Não há informações sobre gravidade aumentada e o desfecho foi de recuperação completa, indicando que a reação foi leve e resolvida sem complicações.

O medicamento Iopromide, contendo o princípio ativo Iopromida, provocou uma alergia a contraste intravenoso, que é uma resposta alérgica do organismo ao agente administrado durante exames. Não há dados que indiquem gravidade significativa e o paciente se recuperou totalmente, sugerindo um quadro leve e autolimitado.

Verzenios, cujo princípio ativo é Abemaciclib, foi associado a um caso de edema glótico, que é um inchaço na região da glote e pode indicar uma reação de hipersensibilidade. Apesar de ser uma manifestação potencialmente preocupante, neste registro não há confirmação de gravidade elevada e o desfecho permanece desconhecido, sendo importante monitorar o paciente para sinais de progressão.

O medicamento Tysabri, com princípio ativo Natalizumabe, esteve relacionado a um evento de exposição a doença transmissível, classificado como hipersensibilidade e que resultou em hospitalização ou prolongamento da

internação, evidenciando gravidade clínica relevante. O desfecho do caso não foi informado, sendo fundamental acompanhamento médico rigoroso devido ao risco aumentado associado à hospitalização.

O medicamento Mavenclad, cujo princípio ativo é a Cladribina, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), classificado como clinicamente significativo e grave devido à presença de sintomas relevantes, conforme indicado pelo registro. A reação envolveu o sistema imunológico e está em processo de recuperação, sugerindo que medidas de suporte e acompanhamento médico foram adotadas para controlar a resposta alérgica. É fundamental manter o acompanhamento até resolução completa e evitar nova exposição ao medicamento.

O medicamento Mounjaro, que contém Tirzepatida, foi relacionado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), considerado grave, pois resultou em hospitalização ou prolongamento da internação, evidenciando a necessidade de intervenção médica imediata. A reação afetou o sistema imunológico e o paciente encontra-se em recuperação, indicando que a conduta incluiu suporte clínico e monitoramento rigoroso. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e manter acompanhamento especializado até a completa resolução do quadro.

O medicamento Henetix, composto por lobitridol, Sodium calcium edetate, Trometamol e Cloridrato de trometamol, foi associado a uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), mas sem gravidade significativa relatada. O paciente já se encontra recuperado, sugerindo que a reação foi leve e manejada adequadamente, provavelmente apenas com suspensão do agente e medidas de suporte, sem necessidade de intervenções adicionais.

O medicamento Cetoprofeno, cujo princípio ativo é o próprio Cetoprofeno, foi relacionado a um quadro de alergia (hipersensibilidade), mas não há informações detalhadas sobre a gravidade, evolução ou desfecho do caso. Dessa forma, é importante que o paciente seja orientado a evitar o uso futuro do medicamento e procure avaliação médica caso apresente sintomas alérgicos novamente.

O medicamento Ultravist, que tem como princípio ativo a Iopromida, foi associado a uma reação de alergia a contraste intravenoso (alergia a contraste), sem gravidade significativa relatada. O paciente já está recuperado, indicando que a reação foi leve e controlada com medidas de suporte, sendo importante informar a equipe médica sobre essa alergia em exames futuros para evitar novas exposições.

O medicamento Xolair, cujo princípio ativo é o Omalizumabe, foi associado a um quadro de anafilaxia, uma reação alérgica grave caracterizada por hipersensibilidade imediata e potencial risco à vida, evidenciada pela classificação como clinicamente significativa e grave. O paciente se recuperou totalmente após a reação, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita, reforçando a necessidade de monitoramento rigoroso durante o uso e de conduta médica imediata em caso de sintomas sugestivos.

O Xolair (Omalizumabe) também foi relacionado a um episódio de anafilaxia com manifestação ocular, descrita como alergia nos olhos, o que indica uma reação alérgica sistêmica com envolvimento ocular. A gravidade foi considerada clinicamente significativa e grave, mas o paciente se recuperou após o evento. A suspeita de relação com o medicamento exige atenção especial a sintomas oculares e sistêmicos após a administração, com orientação para busca imediata de atendimento médico.

A Loratadina, cujo princípio ativo é Loratadina, foi associada a um episódio de alergia caracterizado por hipersensibilidade, mas sem gravidade significativa relatada. O paciente se recuperou completamente após a reação, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita, sugerindo que, embora reações alérgicas possam ocorrer, geralmente são leves e resolutivas, mas devem ser comunicadas ao médico para avaliação e orientação.

O Ibuprofeno, com princípio ativo Ibuprofeno, esteve relacionado a um caso de alergia manifestada por hipersensibilidade, sem gravidade relevante. O paciente se recuperou totalmente, e a relação com o medicamento foi considerada suspeita, indicando que reações alérgicas ao Ibuprofeno podem ocorrer, mas tendem a ser leves e autolimitadas, devendo ser relatadas ao profissional de saúde para orientação adequada.

O medicamento Henetix, cujo princípio ativo é lobitridol, foi associado a uma reação de alergia a contraste intravenoso, caracterizada por resposta alérgica a substâncias químicas utilizadas em exames de imagem. Não houve gravidade significativa, o paciente se recuperou totalmente e a relação com o medicamento foi considerada suspeita, ressaltando a importância de informar antecedentes alérgicos antes do uso de contrastes e de monitorar possíveis reações durante e após o procedimento.

O medicamento Dprev, cujo princípio ativo é o colecalciferol, foi associado ao desenvolvimento de dermatite em um paciente com alergia ao leite. A reação foi classificada como grave devido à presença de anomalia congênita ou malformação ao nascer, e o caso permanece não resolvido até o momento. A suspeita recai sobre o medicamento, e a manifestação sugere uma resposta alérgica do sistema imunológico, sendo fundamental acompanhamento médico especializado para monitoramento e manejo adequado.

O medicamento Colidis, contendo como princípio ativo o *Limosilactobacillus reuteri*, foi relacionado ao surgimento de dermatite em um paciente com alergia ao leite. A gravidade da reação é considerada alta, pois houve registro de anomalia congênita ou malformação ao nascer, e o quadro ainda não foi resolvido. O medicamento é considerado suspeito na origem da reação, indicando a necessidade de avaliação clínica detalhada e acompanhamento contínuo para evitar complicações.

A domperidona, cujo princípio ativo é homônimo, foi associada ao aparecimento de dermatite em um paciente com alergia ao leite. A reação foi considerada grave devido à ocorrência de anomalia congênita ou malformação ao nascer, e o desfecho permanece em andamento, sem resolução. O medicamento é apontado como suspeito, sendo essencial a supervisão médica para investigação e manejo da reação adversa.

O medicamento Prohance, que tem como princípio ativo o gadoteridol, foi relacionado a um episódio de alergia a contraste intravenoso. A reação não foi considerada grave e o paciente se recuperou totalmente após o evento. O medicamento é suspeito de ter causado a reação, que envolveu resposta do sistema imunológico, e não houve complicações persistentes, indicando resolução completa do quadro.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é o gadobutrol, esteve envolvido em um caso de alergia a contraste intravenoso. A reação não foi classificada como grave e o paciente apresentou recuperação total após o evento. O caso foi considerado uma interação, e não houve consequências duradouras, com resolução completa do quadro alérgico.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é a Iopromida, foi associado a um episódio de alergia a contraste, reação que se enquadra nos distúrbios do sistema imunitário e é tecnicamente chamada de hipersensibilidade a substâncias químicas. Neste caso, não há indicação de gravidade elevada, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento, e não há menção de complicações ou necessidade de intervenção médica adicional, sugerindo um quadro leve e autolimitado.

Ultravist, com princípio ativo Iopromida, esteve relacionado a uma reação de alergia a contraste, caracterizada por resposta do sistema imunológico a substâncias químicas utilizadas em exames. O evento não foi considerado grave, já que o paciente se recuperou completamente, e não há relato de complicações, o que indica uma manifestação leve e resolutive.

O uso do medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é Iopromida, resultou em uma alergia a contraste administrado por via intravenosa, uma reação do sistema imunológico a substâncias químicas. Não há evidências de gravidade significativa, pois o paciente se recuperou sem intercorrências, sugerindo um quadro leve e autolimitado.

Ultravist, com princípio ativo Iopromida, foi associado a um episódio de alergia (hipersensibilidade), que é uma resposta do sistema imunológico a medicamentos. Não há indicação de gravidade ou complicações, e o paciente se recuperou totalmente, caracterizando um evento leve e resolvido.

O medicamento Gadovist, cujo princípio ativo é Gadobutrol, foi relacionado a uma reação de alergia medicamentosa (hipersensibilidade), que envolve resposta do sistema imunológico a medicamentos. Não há informações suficientes sobre gravidade, evolução ou desfecho neste caso, impossibilitando uma avaliação mais detalhada da severidade ou da conduta adotada.

O medicamento Primovist, cujo princípio ativo é o gadoxetato dissódico, foi associado a um quadro de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), caracterizado por uma reação do sistema imunológico a uma substância química. Não há indicação de gravidade elevada, pois o caso foi considerado não grave e o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo que a conduta adotada foi suficiente para resolução do quadro.

A Oxaliplatina, com princípio ativo de mesmo nome, desencadeou uma reação alérgica (hipersensibilidade), que é uma resposta imunológica exagerada a medicamentos. Não há informações detalhadas sobre a gravidade, mas o paciente se recuperou completamente, indicando que a reação foi controlada e não houve complicações graves associadas ao evento.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é a Iopromida, esteve relacionado a um episódio de alergia medicamentosa (hipersensibilidade medicamentosa), uma resposta do sistema imunológico a substâncias químicas presentes no contraste. O caso não foi considerado grave e o paciente se recuperou, mostrando que a reação foi adequadamente manejada e não resultou em consequências duradouras.

O medicamento Iopromide, com princípio ativo Iopromida, foi associado a um quadro de edema laríngeo (inchaço na laringe) relacionado à alergia a contraste, uma reação imunológica que pode comprometer as vias aéreas. Apesar do potencial risco desse tipo de reação, o caso não foi classificado como grave e o paciente está em recuperação, indicando que a evolução está sendo favorável e o manejo foi apropriado até o momento.

O medicamento Ultravist, cujo princípio ativo é a Iopromida, provocou uma reação de alergia a contraste, caracterizada por resposta imunológica a substâncias químicas utilizadas em exames. O evento não foi considerado grave e o paciente se recuperou totalmente, sugerindo que a conduta adotada foi eficaz e não houve complicações relevantes.

O medicamento Eritropoyetina, cujo princípio ativo é a epoetina alfa, foi associado a um quadro de alergia caracterizado como hipersensibilidade, pertencente ao grupo dos distúrbios do sistema imunitário. Não há indicação de gravidade elevada neste caso, pois o paciente se recuperou totalmente após o evento, sugerindo uma reação leve e autolimitada. A conduta recomendada é observar o paciente, evitar nova exposição ao medicamento e, caso haja sintomas recorrentes, buscar avaliação com especialista para confirmação diagnóstica e orientação de tratamento.

A Vancomicina, com princípio ativo Vancomycin, desencadeou uma reação alérgica do tipo hipersensibilidade, também classificada entre os distúrbios do sistema imunitário. O caso não foi considerado grave, pois o paciente apresentou recuperação completa após o episódio, indicando uma manifestação leve. Recomenda-se evitar o uso futuro do medicamento e procurar acompanhamento médico para avaliação e definição de alternativas terapêuticas seguras.

O uso de Cefalotina, cujo princípio ativo é cefalotina sódica, resultou em uma reação alérgica descrita como hipersensibilidade, relacionada a distúrbios do sistema imunitário. Não há evidências de gravidade significativa, já que o paciente se recuperou totalmente, sugerindo um quadro leve. A orientação é suspender o medicamento, monitorar possíveis sintomas e buscar avaliação especializada para confirmação da alergia e planejamento de futuras prescrições.

A Dipirona, com princípio ativo metamizol de magnésio, foi associada a um episódio de alergia do tipo hipersensibilidade, enquadrada entre os distúrbios do sistema imunitário. Não há informações suficientes sobre a gravidade ou evolução do caso, portanto, recomenda-se cautela, evitar nova exposição ao medicamento e procurar avaliação médica para esclarecimento diagnóstico e definição de conduta adequada.